

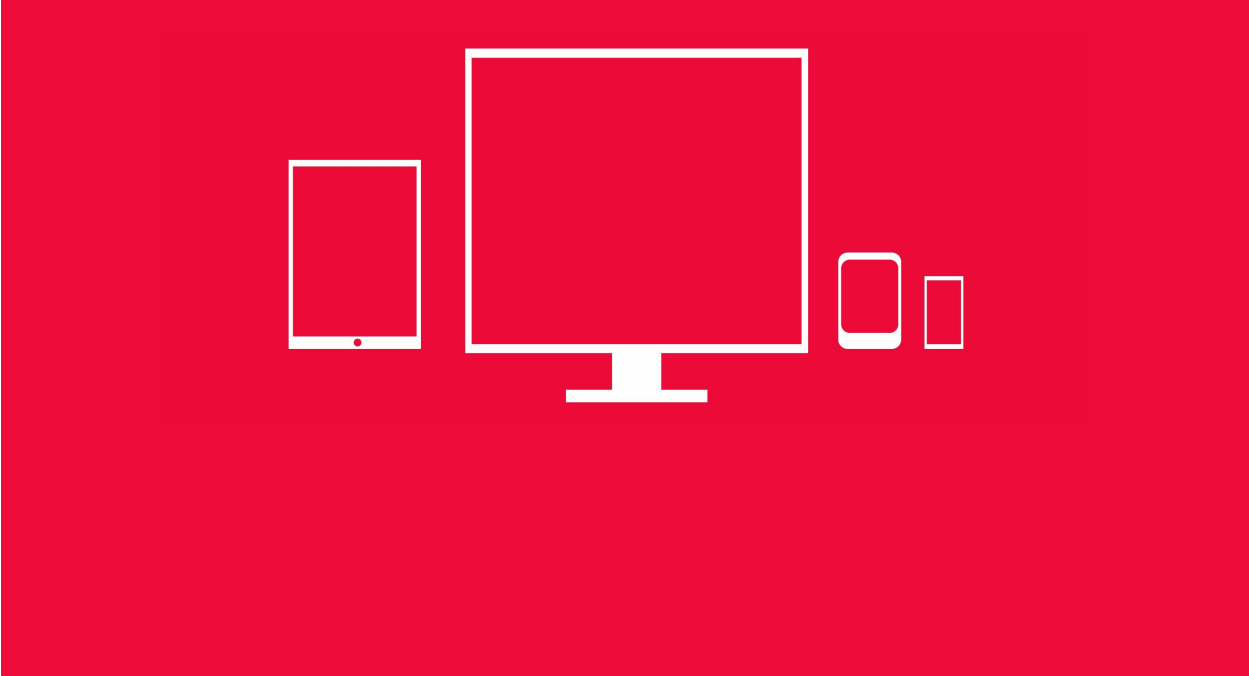
Neury José Botega (organizador)

4ª
edição

Prática Psiquiátrica no Hospital Geral

Interconsulta e Emergência





Aviso

Todo esforço foi feito para garantir a qualidade editorial desta obra, agora em versão digital. Destacamos, contudo, que diferenças na apresentação do conteúdo podem ocorrer em função das características técnicas específicas de cada dispositivo de leitura.

Nota: A medicina é uma ciência em constante evolução. À medida que novas pesquisas e a própria experiência clínica ampliam o nosso conhecimento, são necessárias modificações na terapêutica, onde também se insere o uso de medicamentos. Os autores desta obra consultaram as fontes consideradas confiáveis, num esforço para oferecer informações completas e, geralmente, de acordo com os padrões aceitos à época da publicação. Entretanto, tendo em vista a possibilidade de falha humana ou de alterações nas ciências médicas, os leitores devem confirmar estas informações com outras fontes. Por exemplo, e em particular, os leitores são aconselhados a conferir a bula completa de qualquer medicamento que pretendam administrar, para se certificar de que a informação contida neste livro está correta e de que não houve alteração na dose recomendada nem nas precauções e contraindicações para o seu uso. Essa recomendação é particularmente

importante em relação a medicamentos introduzidos recentemente no mercado farmacêutico ou raramente utilizados.

Neury José Botega (organizador)

Prática Psiquiátrica no Hospital Geral

Interconsulta e Emergência



Versão impressa desta obra: 2017



A Artmed é a editora
oficial da ABP

2017

© Artmed Editora Ltda, 2017

Gerente editorial: *Letícia Bispo de Lima*

Colaboraram nesta edição:

Coordenadora editorial: *Cláudia Bittencourt*

Capa: *Paola Manica*

Imagem da capa: *@bigstockphoto.com/Abstract Background With Curves Lines. Vector Silhouettes Backgrounds*

Ilustrações: *Gilnei da Costa Cunha*

Preparação do original: *Luiza Drissen Signorelli Germano*

Leitura final: *Camila Wisnieski Heck*

Editoração: *Bookabout – Roberto Carlos Moreira Vieira*

Desenvolvimento de eBook: *Loope - design e publicações digitais* | www.loope.com.br

P912 Prática psiquiátrica no hospital geral : interconsulta e
Emergência [recurso eletrônico] / Organizador, Neury José
Botega. – 4. ed. – Porto Alegre : Artmed, 2017.
e-PUB.

Editado como livro impresso em 2017.
ISBN 978-85-8271-430-0

1. Psiquiatria. 2. Prática psiquiátrica – Hospital geral.
I. Botega, Neury José.

CDU 616.89

Catálogo na publicação: Poliana Sanchez de Araujo – CRB 10/2094



Reservados todos os direitos de publicação à
ARTMED EDITORA LTDA., uma empresa do GRUPO A EDUCAÇÃO S.A.
Av. Jerônimo de Ornelas, 670 – Santana
90040-340 Porto Alegre RS
Fone: (51) 3027-7000 Fax: (51) 3027-7070

SÃO PAULO

Rua Doutor Cesário Mota Jr., 63 – Vila Buarque

01221-020 – São Paulo – SP

Fone: (11) 3221-9033

SAC 0800 703-3444 – www.grupoa.com.br

É proibida a duplicação ou reprodução deste volume, no todo ou em parte, sob quaisquer formas ou por quaisquer meios (eletrônico, mecânico, gravação, fotocópia, distribuição na Web e outros), sem permissão expressa da Editora.

A Güerino Botega,
bondade e exemplo,
pela luz que emana e norteia

A Marilda,
pela cumplicidade e dedicação,
todo o meu amor

A Isabela,
nos valores e na escrita que nos unem,
a esperança por um mundo mais justo

Fábio Lopes Rocha, Luiz Alberto Bechelli Hetem, Marcelo Pio de Almeida Fleck, Marco Antônio Alves Brasil, Marco Antônio Bessa e Mário Eduardo Costa Pereira. Carlos Filinto da Silva Cais, Celso Garcia Jr., Fernando Yukio Tomita, João Baptista Laurito Jr. e Lucas Francisco Botequio Mella.

A vocês, minha homenagem e gratidão pela amizade e pelos conhecimentos compartilhados em nossos grupos de estudo.

Autores

Neury José Botega: Psiquiatra. Professor Titular do Departamento de Psicologia Médica e Psiquiatria da Faculdade de Ciências Médicas da Universidade Estadual de Campinas (FCM-Unicamp).

Alcion Sponholz Junior: Psiquiatra e supervisor de emergências em psiquiatria. Mestre e Doutor em Saúde Mental pela Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto, da Universidade de São Paulo (FMRP-USP). Interconsultor psiquiátrico junto à Unidade de Transplante de Medula Óssea do Hospital das Clínicas de Ribeirão Preto (HCRP).

Amilton dos Santos Júnior: Psiquiatra. Mestre em Saúde da Criança e do Adolescente pela Unicamp. Doutor em Ciências da Saúde – Saúde da Criança e do Adolescente – pela Unicamp. Professor da FCM-Unicamp.

Ana Luísa Marques Traballi: Psiquiatra da infância e adolescência. Psiquiatra assistente do Grupo de Assistência e Estudos em Transtornos Alimentares (GETA) da Unicamp. Coordenadora do Centro de Atenção Psicossocial Infantojuvenil (CAPS IJ) Roda Viva.

Antonio Carvalho de Ávila Jacintho: Psiquiatra da infância. Preceptor e professor da Residência Médica em Psiquiatria Infantil e de Adolescentes da FCM-Unicamp.

Carlos Filinto da Silva Cais: Psiquiatra. Mestre e Doutor em Ciências Médicas pela Unicamp. Professor colaborador no Departamento de Psicologia Médica e Psiquiatria da FCM-Unicamp.

Catalina Camas Cabrera: Psiquiatra. Especialista em Violência Doméstica contra Crianças e Adolescentes pelo Laboratório de Estudos da Criança (Lacri) do Instituto de Psicologia da USP. Mestre em Clínica Médica pela FMRP-USP. Doutora em Saúde Mental pela FMRP-USP. Médica assistente do Serviço de Interconsulta em Saúde Mental do HC-FMRP-USP.

Celso Garcia Junior: Psiquiatra. Mestre e Doutor em Ciências Médicas pela Unicamp. Coordenador do GETA e psiquiatra da Unidade de Transplante de Medula Óssea da Unicamp. Docente coordenador das disciplinas de Saúde Mental do Curso de Graduação em Medicina da Faculdade São Leopoldo Mandic.

Clarissa de Rosalmeida Dantas: Psiquiatra. Mestre e Doutora em Ciências Médicas – Saúde Mental – pela FCM-Unicamp. Professora Doutora do Departamento de Psicologia Médica e Psiquiatria da FCM-Unicamp. Membro do Serviço de Interconsulta Psiquiátrica do HC-Unicamp.

Cláudio E. M. Banzato: Psiquiatra. Doutor em Filosofia pela Unicamp. Professor Titular do Departamento de Psicologia Médica e Psiquiatria da FCM-Unicamp.

Danielle L. R. S. Argolo: Psiquiatra.

Danisa Cardoso Graceli: Psiquiatra. Especialista em Dependência Química pela Unidade de Pesquisa em Álcool e Drogas da Universidade Federal de São Paulo (UNIAD/Unifesp).

Eloisa Helena Rubello Valler Celeri: Psiquiatra da infância e adolescência. Mestre e Doutora em Saúde Mental pela Unicamp.

Florindo Stella: Psiquiatra. Doutor em Saúde Mental e em Neurologia pela Unicamp. Professor Adjunto do Instituto de Biociências da Universidade Estadual Paulista (UNESP). Pesquisador e Professor Visitante do Laboratório de Neurociências do Instituto e Departamento de Psiquiatria, Faculdade de Medicina, USP (IPq-FMUSP)

João Baptista Laurito Júnior: Psiquiatra e psicanalista. Coordenador da Unidade de Psiquiatria da Santa Casa de Sorocaba.

João Luiz Pinto e Silva: Tocoginecologista. Professor Colaborador da FCM-Unicamp.

Joel Giglio: Psiquiatra. Especialista em Psicoterapia Analítica Junguiana pela Associação Junguiana do Brasil e pela International Association for Analytical Psychology. Doutor em Ciências Médicas – Saúde Mental – pela Unicamp. Professor Associado do Departamento de Psicologia Médica e Psiquiatria da FCM-Unicamp.

Karina Diniz Oliveira: Psiquiatra e bacharel em Direito. Especialista em Dependência Química pela UNIAD/Unifesp. Professora Doutora do Departamento de Psicologia Médica e Psiquiatria da FCM-Unicamp.

Letícia Maria Furlanetto: Psiquiatra. Especialista em Psiquiatria e Psicoterapia pela Associação Brasileira de Psiquiatria (ABP). Mestre e Doutora em Psiquiatria e Saúde Mental pela Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ). Pós-doutorado em Psiquiatria de Hospital Geral na Rush University, Chicago, Estados Unidos. Professora Associada aposentada do Departamento de Clínica Médica da Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC).

Lucas Francisco Botequio Mella: Psiquiatra. Mestrando em Ciências Médicas na FCM-Unicamp. Médico assistente do Serviço de Psiquiatria Geriátrica e Neuropsiquiatria da Emergência Psiquiátrica e do Centro de Saúde da Comunidade da Unicamp. *Fellowship* em Psiquiatria Geriátrica no Alzheimer's Disease Center, New York University, Estados Unidos.

Luís Fernando Tófoli: Psiquiatra. Especialista em Educação para as Profissões da Saúde pela Universidade Federal do Ceará (UFC). Doutor em Psiquiatria pela USP. Professor Doutor do Departamento de Psicologia Médica e Psiquiatria da FCM-Unicamp. Coordenador do Laboratório de Estudos Interdisciplinares sobre Psicoativos (LEIPSI).

Luiz Antonio Nogueira-Martins: Psiquiatra. Mestre e Doutor em Ciências pela Unifesp. Livre-docente. Professor Adjunto aposentado do Departamento de Psiquiatria da Escola Paulista de Medicina (EPM) da Unifesp.

Luiz Fernando de Almeida Lima e Silva: Psiquiatra. Mestre em Ciências Médicas pela Unicamp. Assistente do Departamento de Psicologia Médica e Psiquiatria da FCM-Unicamp. Coordenador do Serviço de Psiquiatria Geriátrica e Neuropsiquiatria do HC-Unicamp.

Luiz Fernando Paulin: Psiquiatra. Doutor em Saúde Mental pela Unicamp. Professor Associado da disciplina de Psiquiatria e coordenador do Curso de Medicina da Universidade São Francisco – Bragança Paulista.

Marcelo Luís Nomura: Obstetra. Especialista em Medicina Fetal pela Federação Brasileira das Associações de Ginecologia e Obstetrícia (Febrasgo). Mestre e Doutor em Tocoginecologia pela

Unicamp.

Marcelo Ribeiro: Psiquiatra. Especialista em Dependência Química pela UNIAD/Unifesp. Mestre e Doutor em Ciências pela Unifesp. Diretor do Centro de Referência de Álcool, Tabaco e outras Drogas (CRATOD), Secretaria de Estado da Saúde de São Paulo.

Marco Antonio Alves Brasil: Psiquiatra. Mestre e Doutor em Psiquiatria pela UFRJ. Professor Associado da Faculdade de Medicina da UFRJ. Chefe do Serviço de Psiquiatria e Psicologia Médica do Hospital Universitário Clementino Fraga Filho, UFRJ.

Mario Eduardo Costa Pereira: Psiquiatra e psicanalista. Mestre em Ciências Médicas – Saúde Mental – pela FCM-Unicamp. Doutor em Psicopatologia Fundamental e Psicanálise pela Université Paris 7, França. Professor Titular de Psicopatologia Clínica pelo Laboratoire de Psychopathologie Clinique et Psychanalyse da Aix-Marseille Université, França. Livre-docente em Psicopatologia pelo Departamento de Psiquiatria da FCM-Unicamp. Diretor do Laboratório de Psicopatologia: Sujeito e Singularidade (LaPSuS).

Osmar Henrique Della Torre: Psiquiatra. Especialista em Psiquiatria de Infância e Adolescência pela Unicamp. Mestre em Ciências – Saúde da Criança e do Adolescente – pela Unicamp. Assistente do Departamento de Psicologia Médica e Psiquiatria da FCM-Unicamp. Preceptor da Psiquiatria de Infância e da Emergência Psiquiátrica da Pontifícia Universidade Católica de Campinas (PUC-Campinas).

Paulo Dalgalarrodo: Psiquiatra. Mestre em Psiquiatria pela Unicamp. Doutor em Psiquiatria pelo Instituto Central de Saúde Mental de Mannheim, Universidade de Heidelberg, Alemanha. Doutor em Antropologia Social pela Unicamp.

Renata Cruz Soares de Azevedo: Psiquiatra. Doutora em Ciências Médicas – Saúde Mental – pela FCM/Unicamp. Professora Doutora II da FCM/Unicamp. Coordenadora do Ambulatório de Substâncias Psicoativas do HC-Unicamp e coordenadora técnica do Programa de Prevenção ao Uso de Risco de Substâncias Psicoativas da Unicamp.

Renério Fraguas: Psiquiatra. Doutor em Medicina pela USP. Pós-doutorado na Harvard University, Estados Unidos. Livre-docente pela FMUSP.

Ronaldo Laranjeira: Psiquiatra. PhD em Psiquiatria pela Universidade de Londres, Inglaterra. Professor Titular do Departamento de Psiquiatria da Unifesp. Coordenador da UNIAD/Unifesp. Investigador principal do Instituto Nacional de Políticas do Álcool e Drogas (INPAD) do CNPq.

Roosevelt M. S. Cassorla: Psiquiatra e psicanalista. Doutor em Saúde Mental pela Unicamp. Professor Titular do Departamento de Psicologia Médica e Psiquiatria da Unicamp. Membro efetivo e analista didata do Grupo de Estudos Psicanalíticos de Campinas e da Sociedade Brasileira de Psicanálise de São Paulo (SBPSP).

Sabrina Stefanello: Psiquiatra. Mestre e Doutora em Ciências Médicas – Saúde Mental – pela Unicamp. Professora Adjunta do Departamento de Medicina Forense e Psiquiatria na Universidade Federal do Paraná (UFPR). Pós-doutorado em Saúde Coletiva na Unicamp e na Escola de Serviço Social, Faculdade de Artes e Ciências Sociais da Universidade de Montreal, Canadá.

Sandra Fortes: Psiquiatra e professora. Mestre em Psiquiatria pelo Instituto de Psiquiatria da UFRJ. Doutora em Saúde Coletiva pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro (UERJ).

Prefácio

Nesta quarta edição de *Prática psiquiátrica no hospital geral*, há coincidência de comemorações: o Departamento de Psicologia Médica e Psiquiatria da Unicamp completou 50 anos, nosso Serviço de Interconsulta, 30, e este livro, 15 anos.

Vários dos atuais colaboradores do livro – um terço – nele estudaram e agora são profissionais que se dedicam à assistência e ao ensino no Hospital de Clínicas da Unicamp. Essa feliz circunstância renova e fortalece o espírito de um livro que se tornou companheiro de muitos estudantes e de jovens profissionais.

Há nos alicerces desta obra elementos da psicologia médica e da psiquiatria, em uma combinação que a vivência clínica dosou e que os anos de docência transformaram em um texto que amadurece com o leitor. Encontram-se aqui as informações que auxiliam na condução de um caso clínico, e também os fundamentos da interação empreendida com pacientes e com colegas de outras especialidades.

Em tempos de amplo acesso à internet, este livro quis continuar sendo um manual. Teve que deter a escalada crescente de páginas desde a primeira edição, a fim de permanecer norteador e pragmático:

- O capítulo introdutório contém uma visão histórica e crítica sobre o papel que o hospital geral desempenha – em países mais desenvolvidos, mas ainda não no Brasil – dentro de uma rede de atenção ao doente mental.
- O Capítulo 10, de psiquiatria geriátrica, focaliza a avaliação e o manejo de sintomas cognitivos e neuropsiquiátricos em idosos internados.
- O Capítulo 12, sobre pacientes acometidos por transtornos mentais graves, aborda o problema da comorbidade e expande o escopo do livro às enfermarias de psiquiatria em hospitais gerais.
- Conceitos básicos sobre a ação dos psicofármacos encontram-se reunidos no Capítulo 23, um texto para lembrar médicos e para facilitar o entendimento de alunos e outros profissionais.
- O Capítulo 26, de abordagem psicodinâmica, nasce na psicologia médica e condensa a essência do que um profissional da saúde pode oferecer a pacientes que vivenciam a catástrofe e a crise existencial: uma escuta privilegiada.

Tenho muito que agradecer ao profissionalismo da Artmed e a esse time de colegas que a mim se uniram para compor a história deste livro. Sou grato, também, aos pacientes e médicos residentes que sempre fomentaram a dedicação à clínica e o desejo de seguir estudando e compartilhando.

Neury José Botega

Sumário

- 1** A psiquiatria no hospital geral
Neury José Botega
- 2** O paciente diante da doença e da hospitalização
Neury José Botega
- 3** O médico e o cuidar
Neury José Botega
- 4** Pacientes-problema: um impasse
Neury José Botega
- 5** Relação entre médicos
Neury José Botega
- 6** Saúde mental dos profissionais da saúde
Luiz Antonio Nogueira-Martins
- 7** Interconsulta psiquiátrica: visão psicodinâmica
Neury José Botega
- 8** Interconsulta psiquiátrica: aspectos da técnica
Neury José Botega, Clarissa de Rosalmeida Dantas

Apêndice: Formação profissional e organização de serviços
- 9** Avaliação do paciente
Neury José Botega, Paulo Dalgalarrrondo

Anexos
- 10** Interconsulta de pacientes idosos
Lucas Francisco Botequão Mella, Florindo Stella

Anexos
- 11** Interconsulta de crianças
Antonio Carvalho de Ávila Jacintho, Eloisa Helena Rubello Valler Celeri
- 12** O paciente com transtorno mental grave
Cláudio E. M. Banzato, Paulo Dalgalarrrondo
- 13** Agitação psicomotora
Antonio Carvalho de Ávila, Jacintho Florindo Stella, João Baptista Laurito Júnior
- 14** *Delirium* (estado confusional agudo)
Luiz Fernando de Almeida Lima e Silva, Amilton dos Santos Júnior
- 15** Depressão
Neury José Botega, Letícia Maria Furlanetto, Renério Fraguas
- 16** Comportamento suicida

Neury José Botega, Carlos Filinto da Silva Cais

Anexo

17 Somatização

Luís Fernando Tófoli, Sandra Fortes, Marco Antonio Alves Brasil, Neury José Botega

18 Ansiedade e insônia

Catalina Camas Cabrera, Alcion Sponholz Junior

19 Dependência de substâncias psicoativas: conceitos e abordagem

Renata Cruz Soares de Azevedo, Karina Diniz Oliveira

Apêndice: Dor e dependência de opioides

20 Substâncias psicoativas: emergências psiquiátricas

Marcelo Ribeiro, Danisa Cardoso Graceli, Ronaldo Laranjeira

21 Gravidez e puerpério

Neury José Botega, João Luiz Pinto e Silva, Marcelo Luís Nomura

22 Transtornos alimentares no hospital geral

Celso Garcia Junior, Ana Luísa Marques Traballi, Danielle L. R. S. Argolo

23 Psicofármacos: conceitos básicos

Amilton dos Santos Júnior, Neury José Botega, Osmar Henrique Della Torre

24 Psicofármacos: uso em situações clínicas especiais

Neury José Botega, Celso Garcia Junior, Sabrina Stefanello, Carlos Filinto da Silva Cais

25 Psicofármacos: reações adversas e intoxicações

Amilton dos Santos Júnior, Luiz Fernando de Almeida Lima e Silva, Luiz Fernando Paulin

26 Crise: abordagem psicodinâmica

Neury José Botega, Mario Eduardo Costa Pereira, Joel Giglio

Apêndice 1: Respiração diafragmática e meditação (orientações para os pacientes)

Apêndice 2: Relaxamento progressivo (orientações para o paciente)

27 A morte e o morrer: aspectos psicodinâmicos

Roosevelt M. S. Cassorla

28 Aspectos éticos e legais

Neury José Botega, Luís Fernando Tófoli



A psiquiatria no hospital geral

Neury José Botega

Duas perspectivas no desenvolvimento da psiquiatria no hospital geral são aqui destacadas: uma histórica, relacionada à reestruturação da assistência ao doente mental e ao papel do hospital geral em uma rede diversificada de serviços, e outra clínica, relacionada à integração de cuidados em saúde mental e ao desenvolvimento da interconsulta psiquiátrica. A instalação de enfermarias de psiquiatria e de serviços de interconsulta propiciou à psiquiatria um espaço privilegiado no âmbito do hospital geral. No modelo de atenção à saúde mental atualmente em vigor no Brasil, o papel da unidade de psiquiatria no hospital geral é reconhecido pelos documentos oficiais, mas ainda é subdimensionado na prática. Na área específica de interconsulta, ainda há muito a ser conquistado nos seguintes campos: ampliação da disponibilidade e das modalidades de atendimento, remuneração do interconsultor e produção de estudos científicos.

HISTÓRICO

A medicina evoluiu à medida que as doenças puderam ser pensadas como fenômenos naturais. A psiquiatria, por sua vez, tardou para se firmar fora das concepções sobrenaturais. No século XIX, os manicômios fizeram essa especialidade viver, literalmente, entre muros, distante do campo médico. Momentos históricos ora aproximaram psiquiatria e medicina, ora as afastaram. Ao longo do século XX, o movimento psicossomático, o surgimento dos psicofármacos, as classificações nosográficas, os estudos epidemiológicos e a neurociência aproximaram o modo de ver e de falar do psiquiatra ao de seus colegas de outras especialidades.

Os primeiros “hospitais gerais” surgiram na Europa medieval à margem das estradas. Eles tinham um sentido muito diferente do atual, uma vez que constituíam um meio de combinar exclusão, caridade e assistência espiritual a indivíduos pobres e agonizantes. A ciência médica foi incorporada tardiamente, apenas em meados do século XVIII.^{1,2}

Em 1728, Thomas Guy criou, em Londres, o que podemos considerar a primeira enfermaria de psiquiatria em hospital geral, com 20 leitos, no St. Thomas Hospital. Outras unidades semelhantes foram abertas em diversos hospitais ingleses, mas não sobreviveram além da metade do século XIX. Os recursos terapêuticos para o tratamento dos transtornos do comportamento não se desenvolviam como no restante da medicina, e os doentes mentais passaram a ser mantidos em isolamento, em grandes hospitais psiquiátricos. A psiquiatria adentrou o século XX marcada por um modelo assistencial asilar.²

O início das unidades de psiquiatria em hospitais gerais (UPHG) em seu sentido moderno (ou seja, com planejamento terapêutico, integração à medicina geral, internações breves, com rápido retorno à comunidade de origem, e serviços de interconsulta e de emergência) deu-se em 1902, no Albany Medical Center, em Nova York. Outras foram surgindo, muito esparsamente, ao longo das décadas de 1920 e 1930.^{1,3}

Após a II Guerra, observou-se um grande crescimento no número de UPHG, sobretudo nos Estados Unidos. Alguns condicionantes para tal desenvolvimento foram:^{3,4}

- Durante a guerra, houve a experiência de tratar doentes mentais em hospitais de campanha, o que ensejou a possibilidade de oferecer tratamento a doentes mentais em hospitais gerais.
- No esteio da desumanidade dos campos de concentração, a crítica aos grandes hospitais psiquiátricos denunciou sua dimensão segregadora e estigmatizante.
- Vários países do hemisfério norte adotaram uma política de bem-estar social (*welfare state*), a partir da qual o Estado passou a ter um papel fundamental na regulação social, incluindo-se a área de assistência e proteção aos doentes.
- A proposta de saúde pública comunitária norte-americana, com planejamento e esforços em reabilitação, fortaleceu a ideia de que a internação psiquiátrica não mais deveria ser o centro do tratamento de doentes mentais. Este deveria se dar na comunidade, respaldado por estruturas assistenciais extramurais.
- A adequação dos hospitais psiquiátricos e seus métodos terapêuticos foi radicalmente questionada, e a Itália, em 1978, foi o primeiro país do mundo a aprovar uma lei

antimanicomial.

- O desenvolvimento de abordagens terapêuticas que viabilizaram e agilizaram o tratamento de quadros psiquiátricos graves, particularmente a eletroconvulsoterapia e a psicofarmacoterapia.
- O desenvolvimento de abordagens psicoterapêuticas (uso da psicanálise em instituições, técnicas grupais, psicoterapia breve, etc.) e socioterapêuticas (terapia ocupacional, laborterapia, comunidade terapêutica).
- O reconhecimento crescente da importância do ensino de psicologia médica e de psiquiatria nos cursos de medicina, ressaltando a importância das UPHG em hospitais gerais de ensino, bem como da formação em saúde mental, em geral, em todas as profissões da área da saúde.

Algumas das vantagens de uma UPHG são:

- Diminuição do estigma: o doente mental no hospital geral passaria a ser visto como um doente semelhante aos outros.
- Proximidade e acesso: hospitais gerais mais próximos e acessíveis às populações atendidas, o que favorece a regionalização e a continuidade da assistência na rede local de cuidados, bem como o tratamento mais precoce dos transtornos mentais.
- Maior transparência da prática psiquiátrica: os hospitais gerais permitem uma melhor observação, ou mesmo fiscalização, contra possíveis abusos e maus-tratos.
- Melhor atenção à saúde física: há maior disponibilidade de médicos de diversas especialidades e recursos diagnósticos, facilitando o reconhecimento e o tratamento de doenças e intercorrências clínicas (ver, no Cap. 12, a discussão da alta prevalência dessas condições em doentes mentais).
- Maior intercâmbio interdisciplinar com outras especialidades médicas, favorecendo a assistência, a pesquisa e a formação de profissionais da saúde.

Algumas desvantagens das UPHG também têm sido apontadas:

- Limitação e inadequação do espaço físico: a maioria dos hospitais gerais não conta com pátios para exposição solar, áreas verdes, áreas para esportes, etc.
- Devido a uma excessiva adesão ao modelo médico, o tratamento é centrado em terapêuticas somáticas.
- A ênfase em tratamentos sintomatológicos pode inibir a atenção à subjetividade dos pacientes, havendo o perigo de uma “cultura manicomial” dentro de uma UPHG.
- As internações em hospitais gerais costumam ser breves. Altas precoces, sem adequado acompanhamento dos pacientes em serviços ambulatoriais, implicam maior número de reinternações e dificuldade na reabilitação.

No hospital geral, o processo de instalação de serviços de saúde mental e de interação mútua entre a psiquiatria e outras especialidades foi gradual; não foi simples, nem fácil, tendo que superar, até os dias atuais, muitas resistências.³

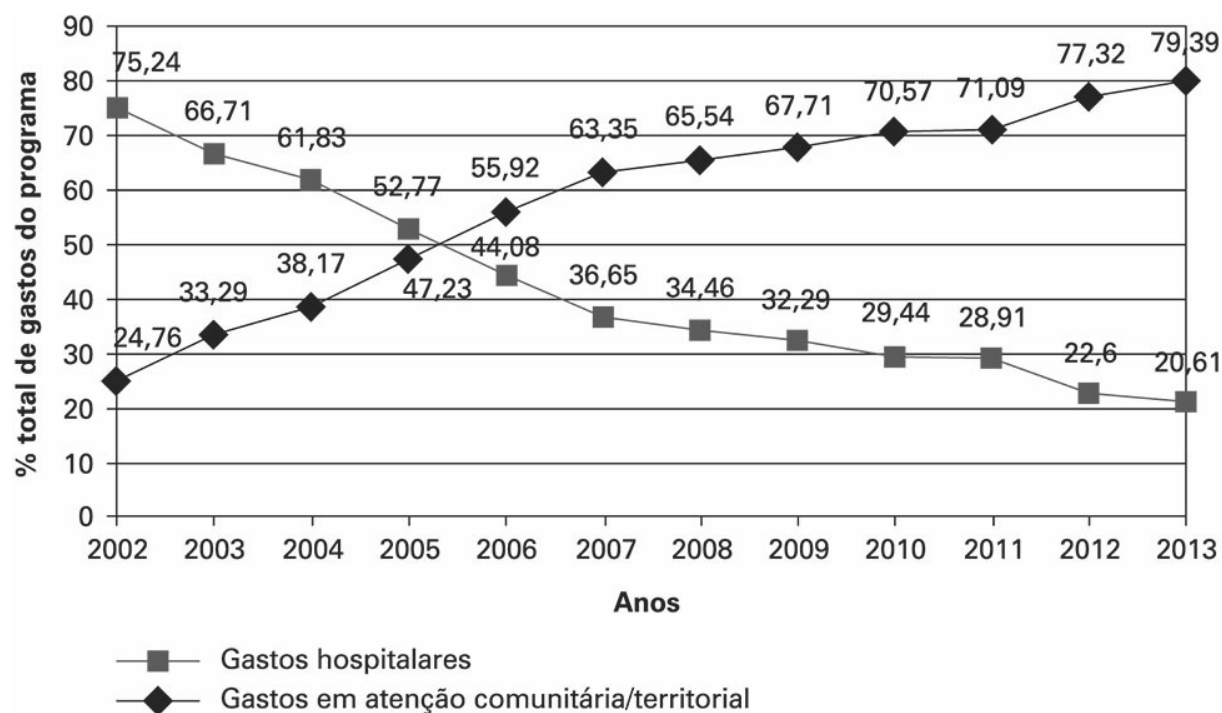
América do Sul e Brasil

Na América colonial, era costume encaminhar os “alienados” para as chamadas “louquerias” dos hospitais religiosos. No Brasil, a exemplo do que ocorria nos territórios espanhóis, o destino dos doentes mentais dependia do estrato social a que pertenciam. Os mais pobres eram encaminhados às prisões ou às Santas Casas, onde geralmente havia, nos porões, celas nas quais os doentes mentais permaneciam confinados.⁵

Inspirada no modelo da Casa-Mãe de Lisboa, a Irmandade de Misericórdia chegou ao Brasil em 1543, com a fundação da Santa Casa de Santos. Mais tarde, com a criação de novos hospitais, ela se tornou a base assistencial hospitalar da colônia. Muitos desses hospitais reservavam um espaço (“casinha de doudos”) para a acomodação de doentes mentais.⁶

Embora haja diferenças econômicas e culturais marcantes na América do Sul, os grandes hospícios começaram a proliferar a partir do século XIX. Até a década de 1970, a assistência mental ficou a cargo dos grandes hospitais psiquiátricos, em localizações afastadas dos grandes centros urbanos. As políticas de saúde na maioria dos países estavam voltadas para as doenças infectocontagiosas, a atenção materno-infantil e as carências alimentares, com pouca atenção para a saúde mental. Na década de 1980, surgiram os movimentos em defesa dos direitos civis e a introdução de novas ideias a respeito da atenção psiquiátrica, inspiradas por experiências realizadas em outros países, notadamente Itália, Inglaterra e Estados Unidos.⁷

No Brasil, a reestruturação da atenção ao doente mental deu-se no fim da década de 1980. Foi inspirada pela experiência italiana e teve como objetivos a desinstitucionalização dos doentes mentais e o desenvolvimento de uma rede extra-hospitalar capaz de garantir a reinserção social e a cidadania. A prioridade dos investimentos voltou-se para os centros de atenção psicossocial (CAPS) e outros programas e serviços na comunidade (Fig. 1.1).^{8,9}



Fonte: Subsecretaria de Planejamento e Orçamento (SPO/MS), DATASUS/MS e Coordenação Geral de Saúde Mental, Álcool e Outras Drogas/DAPES/SAS/MS

FIGURA 1.1 Proporção de recursos federais destinados à saúde mental em serviços hospitalares e de atenção comunitária/territorial.

Fonte: Ministério da Saúde.⁹

Mais recentemente, tem-se questionado a adequação estrutural e funcional, bem como a efetividade, dos CAPS, capazes de gerar uma nova cronicidade.^{10,11}

Ademais, a escassez de oferta de serviços de atenção aos casos mais graves e agudos, bem como o predomínio dos leitos em hospitais psiquiátricos, em detrimento dos hospitais gerais, entram em contradição com o modelo de experiências bem-sucedidas em outros países.¹²⁻¹⁴

ENFERMARIAS DE PSIQUIATRIA

No Brasil, as primeiras enfermarias de psiquiatria em hospital geral surgiram na década de 1950. Em 1954, foi criada a primeira UPHG, no Hospital das Clínicas da Universidade da Bahia. Esta contava com seis leitos para mulheres e um ambulatório de psiquiatria localizado na mesma instituição. No mesmo ano, foi organizada outra UPHG no Hospital dos Comerciários de São Paulo. Em 1957, no Hospital Pedro II, da Universidade Federal de Pernambuco, estabeleceu-se outra UPHG, com 20 leitos.^{15,16}

As UPHG cresceram numericamente na década de 1980 e na primeira metade da década de 1990, principalmente no Sudeste e no Sul (com 43 e 32%, respectivamente, do total). Elas eram localizadas majoritariamente em instituições públicas (59%) e filantrópicas (33%), com média de 20 leitos.^{17,18}

Ao fim de 2014, havia, no País, 189 hospitais psiquiátricos (25.988 leitos) e 167 UPHG (4.620 leitos).⁹ A Tabela 1.1 compara o número de leitos e o número anual de internações em cada modalidade desses serviços entre países selecionados e calculados para cada 100 mil habitantes. Em termos globais, segundo dados da Organização Mundial da Saúde, a tendência é de decréscimo no número de leitos em hospitais psiquiátricos e de aumento em enfermarias de psiquiatria em hospitais gerais.¹⁹

Tabela 1.1

Número de instituições psiquiátricas, leitos e internações por 100 mil habitantes, em países selecionados, em 2014

País	Hospitais psiquiátricos			Enfermarias de psiquiatria em hospitais gerais		
	Total de hospitais	Por 100 mil habitantes		Total de enfermarias	Por 100 mil habitantes	
		Leitos	Internações anuais		Leitos	Internações anuais
Brasil	189	11,6	216	167	0,4	60,8
Chile	4	6,5	27,8	31	5,8	58,6
Colômbia	82	8,7	55,6	40	?	?
Estados Unidos	648	23,6	53	1.176	11,6	59,8
Espanha	98	26,8	54,6	163	11,9	163,8
Itália	6*	1,5	0,4	370	9,5	?

? = Sem dados * Hospitais psiquiátricos forenses

Fonte: Com base em World Health Organization.¹⁹

O Ministério da Saúde reconhece a importância estratégica das UPHG em uma rede de serviços de saúde mental; mais em documentos oficiais e menos na prática. O total de leitos em UPHG – enfatiza-se que os leitos referidos são em *enfermaria* de psiquiatria – aumentou apenas discretamente ao longo das duas últimas décadas, com exceção do Rio Grande do Sul. A partir do baixo valor pago pelo Governo Federal por uma diária em UPHG – estimado em seis vezes menor do que o necessário²⁰ – há pouco estímulo para a abertura de enfermarias de psiquiatria em hospitais gerais. Isso coloca o Brasil na contramão da tendência internacional.^{14,21}

O Rio Grande do Sul, antecipando-se à Lei Federal nº 10.216, que dispõe sobre a “[...] proteção e os direitos das pessoas portadoras de transtornos mentais e redireciona o modelo

assistencial em saúde mental”, aprovou uma lei de reforma da atenção em saúde mental de teor semelhante nove anos antes.²² Posteriormente, o governo gaúcho estabeleceu critérios para a distribuição de incentivos financeiros a instituições que já contassem com UPHG, bem como para a abertura de novos leitos de psiquiatria em hospitais gerais. Em 2012, a maioria (64%) dos leitos psiquiátricos disponíveis no Estado já se encontrava em hospitais gerais.²³

Ao mesmo tempo que a rede de serviços de saúde mental comunitária se expandiu, houve, no Rio Grande do Sul, aumento do número de internações psiquiátricas acompanhado de menor tempo de permanência hospitalar, maior diversidade de gênero (aumento de internação de mulheres) e de causas de hospitalização, entre as quais se destacam as relacionadas ao uso de *crack*, álcool e outras drogas.²⁴ Fenômeno semelhante ocorreu em outros locais do País.²⁵

A reestruturação da assistência em saúde mental indica, desde sua origem, que os recursos aplicados em hospitalizações poderiam ser revertidos para a manutenção, o aprimoramento e a ampliação do atendimento em serviços substitutivos. Há que se considerar, no entanto, que a ampliação do acesso da população a serviços de saúde mental possa levar ao crescimento da demanda em todos os níveis de atenção, incluindo o hospitalar.²⁴ De fato, a implantação de serviços comunitários de saúde mental não tem levado à extinção da necessidade de internações hospitalares no Brasil nem em outros países.¹⁴

Leitos de saúde mental em enfermarias de clínica médica

A partir de 2012, o Ministério da Saúde passou a “habilitar” leitos de saúde mental em enfermarias de clínica médica para internações de curta duração, no contexto das redes de atenção psicossocial (RAPS), fazendo jus ao custeio diferenciado. Tal recurso visa à “[...] atenção às comorbidades clínicas decorrentes de substâncias psicoativas, em especial de abstinências e intoxicações graves, e ao manejo de situações de crise em saúde mental”.²⁶ No entanto, a impressão que temos é a de que esses “leitos de saúde mental” serão a continuação da malfadada intenção de considerar os CAPS III como serviços de maior complexidade e atenção emergencial, “[...] o ponto de atenção estratégico no cuidado e responsabilização pelas situações de crise”.²⁶

Os pacientes que mais precisam de internação psiquiátrica são, justamente, os que não podem ser mantidos em leitos de saúde mental. Uma enfermaria de clínica médica não é adequada ao difícil manejo de pacientes psicóticos agudos, muitas vezes com transtornos comportamentais e agitação psicomotora. O mesmo se pode dizer em relação a pacientes que correm risco de suicídio ou de fuga, por exemplo. A capacitação profissional e o manejo diferenciado da equipe assistencial de uma UPHG são imprescindíveis em situações como essas.

Enfatiza-se que os pacientes mais graves, que não podem ser acolhidos pelo CAPS III, muito provavelmente não serão aceitos em uma enfermaria de clínica médica. Há necessidade de diagnóstico diferencial e de tratamento intensivo, o que só uma UPHG pode oferecer. Ou seja, leitos *psiquiátricos* devem estar em uma enfermaria de psiquiatria, um recurso assistencial que ocupa um espaço delimitado e que conta com instalações adequadas, equipe multiprofissional treinada, recursos diagnósticos e processos terapêuticos efetivos.

Em um hospital geral, não é possível recorrer a leitos de saúde mental para o que deveria ser feito em uma “enfermaria de psiquiatria”. Há, nas políticas públicas do País, a tendência de colocar a psiquiatria em segundo plano, quando se fala em saúde mental ou psicossocial. Um bom sistema de atenção ao doente mental não deve ser centrado no hospital nem no CAPS. Ele requer equilíbrio entre os recursos oferecidos pela internação psiquiátrica e por programas e serviços comunitários. Assim pensa a maioria dos especialistas em serviços de saúde mental consultados em diversos países.¹⁴

MORBIDADE PSIQUIÁTRICA GERAL

Nesta seção, ao examinarmos a associação entre distúrbios físicos e transtornos mentais presentes em pacientes internados em enfermarias clínicas e cirúrgicas, privilegiamos a visão epidemiológica, por razões de didática e pragmatismo.

Ademais, vale lembrar que a concomitância de distúrbios orgânicos e transtornos mentais, evidenciada por diversos estudos, tem caráter descritivo e correlacional. Isso desaconselha a utilização inequívoca e generalizada de certas expressões, como “fator precipitante”, “reação”, “complicação”, bem como o embate sobre modelos de causalidade. Reconhecemos, no entanto, que, diante da limitação de nossos conhecimentos, a linguagem empregada em muitas situações corriqueiras remete ao dualismo cartesiano.

Outra dificuldade conhecida é que, tanto no hospital geral quanto na atenção básica, torna-se difícil diferenciar “casos” de “não casos” psiquiátricos. Isso se deve à combinação de doença física, efeitos adversos de medicamentos, sofrimento psíquico, estilo de vida e problemas sociais. Quando critérios diagnósticos mais restritos são utilizados no âmbito do hospital geral, apenas uma pequena proporção de pacientes acaba recebendo um diagnóstico psiquiátrico formal.

Enfermarias clínicas e cirúrgicas

A frequência de transtornos psiquiátricos em pacientes internados em hospitais gerais é variável, dependente da população estudada (características sociodemográficas, tipo de enfermidade, gravidade, cronicidade, etc.) e de definições metodológicas (critérios de inclusão, instrumentos de pesquisa, ponto de corte, definição de “caso”, etc.). A morbidade psiquiátrica é maior em enfermarias de emergência e em unidades que lidam com pacientes em estado crítico.

Um estudo que avaliou 4.352 pacientes internados em enfermarias do Hospital de Clínicas da Unicamp (HC Unicamp) encontrou taxas de 14% de depressão, 10% de abuso/dependência de álcool, 17% de dependência de nicotina e de 5% de risco de suicídio.^{27,28} Reações de ajustamento com sintomas de ansiedade e de depressão, como também episódios depressivos, estão entre os mais frequentes. O quadro confusional agudo, ou *delirium*, é uma síndrome comum, mais encontrada em idosos, pacientes de UTI e unidade de queimados. Abuso e dependência de álcool são problemas muito frequentes e subdiagnosticados.

Ambulatórios

Um inquérito epidemiológico com 2.792 pacientes ambulatoriais, realizado no Hospital Universitário Pedro Ernesto (UERJ), revelou morbidade psiquiátrica de 38%. Os diagnósticos mais frequentes foram transtorno de ansiedade generalizada (23%), episódio depressivo (16%), transtorno de sintomas somáticos (9%), dependência ou uso nocivo de álcool (6%), distímia (2,5%) e transtorno de ansiedade de doença (1%).²⁹

Interconsulta psiquiátrica

A maioria dos estudos realizados no Brasil indica que de 1 a 2,5% dos pacientes internados em hospitais gerais são avaliados pela interconsulta psiquiátrica.³⁰⁻³²

Um estudo de caso-controle (47 interconsultas psiquiátricas e 94 controles) foi realizado com pacientes internados no Hospital das Clínicas de Botucatu (UNESP). Um total de 95% dos casos de interconsulta e de 28% dos controles recebeu diagnósticos psiquiátricos. No primeiro grupo, predominaram transtorno mental orgânico (30%), transtorno decorrente do uso de álcool (21%), transtornos de ansiedade (21%), transtornos depressivos (13%) e transtorno conversivo (11%). Entre os pacientes-controle, o mais comum foi a ausência de diagnóstico psiquiátrico (72%), seguida de transtornos de ansiedade (10%), transtorno decorrente do uso de álcool (7%), transtornos depressivos (7%) e transtorno mental orgânico (3%).³³

Baixa detecção de transtornos mentais

Algumas características apresentadas pelos pacientes parecem ser mais facilmente reconhecidas, como traços histéricos, hipocondríacos e depressivos. Ao contrário, problemas referentes à vida sexual, psicossomáticos e alcoolismo geralmente passam despercebidos.³⁴ O Quadro 1.1 reúne alguns fatores aventados para se compreender a dificuldade dos médicos em reconhecer, diagnosticar e registrar transtornos mentais.

QUADRO 1.1

Fatores relacionados a dificuldades no reconhecimento e no diagnóstico de transtornos mentais

- Pacientes queixam-se do corpo, não relatando problemas psicológicos.
- As pistas fornecidas pelo paciente a respeito de seu estado emocional não são captadas pelo médico.
- O médico aceita a negação do paciente em relação a seus problemas.
- Falta de treinamento profissional adequado em saúde mental.
- Falta de tempo e de privacidade, em alguns ambientes, para conversar.
- Médicos detêm a investigação ao encontrarem uma causa física.
- Sintomas considerados “compreensíveis”, “benignos” ou “fazendo parte” do quadro clínico.
- O médico reconhece um problema, mas não faz o diagnóstico psiquiátrico correspondente.
- O médico só faz o diagnóstico psiquiátrico quando se sente seguro no manejo do caso.
- O problema é reconhecido e diagnosticado, mas não se faz o registro no prontuário.

A maior parte dos pacientes não reconhecidos como acometidos por transtornos psiquiátricos apresenta-se ao médico com queixas físicas. Essa maneira como dificuldades psicossociais são expressas, a atitude dos médicos em relação à doença mental e à psiquiatria, seus sentimentos diante do paciente, bem como as características dos locais de atendimento, são alguns dos fatores que podem influenciar a capacidade profissional de detectar problemas mentais nos pacientes.

Frequentemente, médicos lidam com muitos pacientes que manifestam problemas mentais sem saber exatamente com quais termos descrevê-los. Reconhecem um comportamento que consideram desviante e a ele atribuem um nome fora dos sistemas clássicos de descrição dos transtornos mentais, como “poliqueixoso”, “somatizador”, “peripaque”, “piti” e “histérico”, entre

os mais usados.³⁵ O Capítulo 17 discute como a rotulação de “somatização” segue uma lógica de defesa psicológica – deixa o problema psicossocial do paciente fora da área de competência do médico, que, assim, continua a se sentir competente naquilo em que foi “treinado”, ou seja, lidar apenas com o corpo.

A distância observada entre o número de encaminhamentos e o total de pacientes que, supostamente, necessitariam de tratamento psiquiátrico levou muitos pesquisadores a questionar por que algumas pessoas são encaminhadas a um profissional de saúde mental, e outras, que podem estar em condições tão ou mais graves, não o são. Uma vez que o médico tenha detectado alguns pacientes com transtornos mentais, quem será e quem não será encaminhado? Quais os diferentes fatores que interferem nesse processo?

A partir de vários estudos realizados na atenção primária, Goldberg e Huxley³⁶ propuseram um esquema que se tornou clássico para representar o processo pelo qual pessoas da comunidade chegam aos serviços de psiquiatria (Fig. 1.2). São descritos vários níveis de atendimento pelos quais o paciente passa, à medida que alguns filtros de seleção vão sendo aplicados. Em cada um desses filtros, agem fatores relacionados às características do indivíduo, das pessoas que vivem a seu lado e de seu médico geral. Como enfatizado pelos autores, é interessante observar que os fatores que reduzem a prevalência de 230 casos psiquiátricos no consultório do médico geral (nível 2 da Fig. 1.2) para 17 encaminhamentos ao psiquiatra (nível 4) operam dentro do consultório do médico geral.

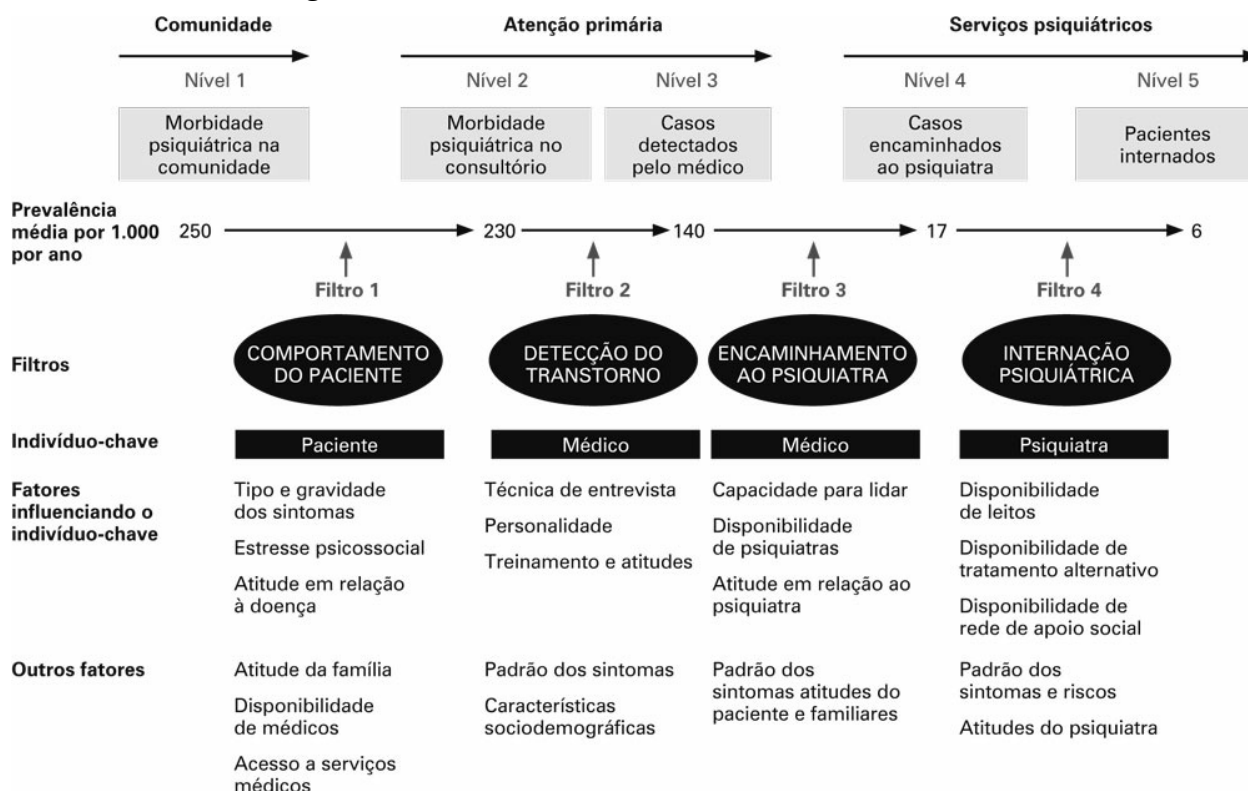


FIGURA 1.2 Níveis de atenção e filtros que condicionam a detecção e o encaminhamento de transtornos mentais ao psiquiatra.

Fonte: Com base em Goldberg e Huxley³⁶.

Com adaptações, esse modelo também pode ser aplicado ao contexto do hospital geral, ambiente no qual a detecção de transtornos mentais e o encaminhamento ao psiquiatra ganham nova complexidade (Fig.1.3). A elucidação dos componentes desse modelo e o entendimento do dinamismo subjacente ao processo de encaminhamento é algo fundamental para o psiquiatra que trabalha no hospital geral.

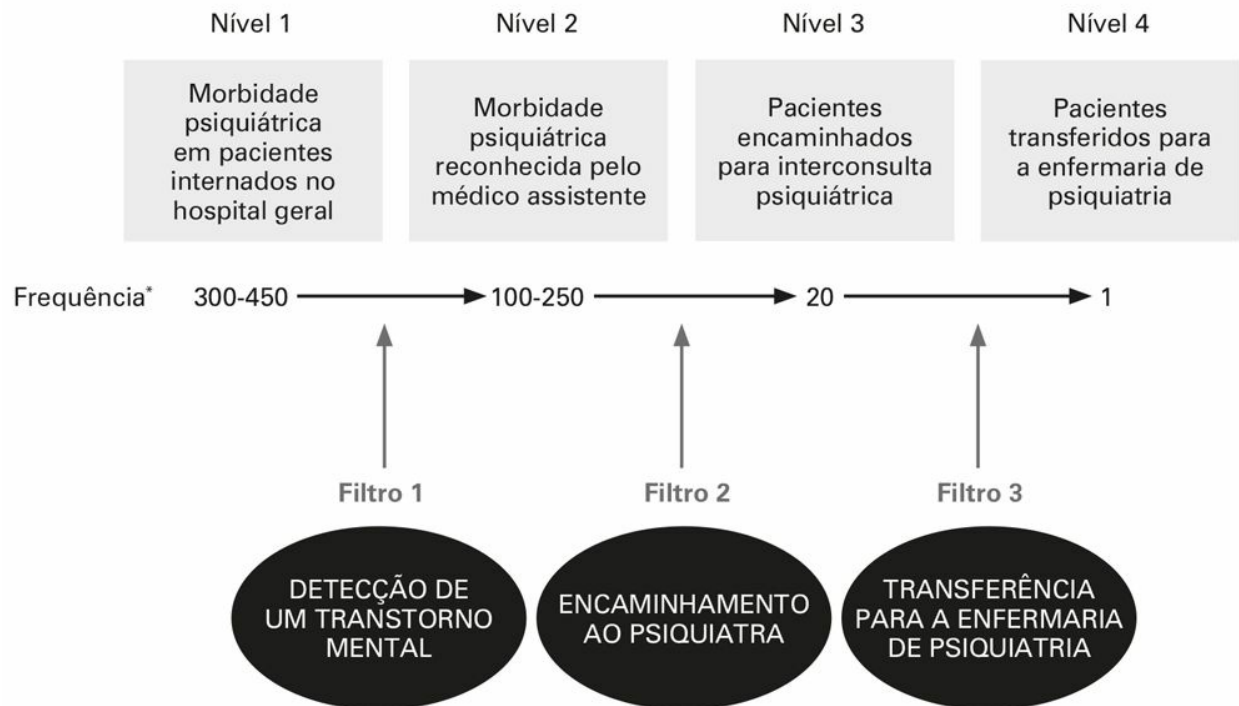


FIGURA 1.3 Adaptação do esquema proposto por Goldberg e Huxley ao hospital geral.

* Por 1.000 internações, segundo estudos realizados no Hospital de Clínicas da Unicamp.

Fonte: Goldberg e Huxley.³⁶

As cifras da Figura 1.3 foram baseadas em trabalhos realizados no HC Unicamp. Diversos fatores, distribuídos nos três filtros, fazem cair uma prevalência de 300-450 casos psiquiátricos por mil internações para 20 interconsultas realizadas. Isso quer dizer que, no hospital como um todo, apenas 1 em cada 18 pacientes internados, que seriam casos psiquiátricos, é visto pela psiquiatria. Observa-se que muito raramente é necessário transferir um paciente visto em interconsulta para a enfermaria de psiquiatria, o que ocorre em, aproximadamente, 5% dos casos.³²

Os Capítulos 2 a 5 e o 7 abordam alguns dos fatores (filtro 2) que atuam na decisão do médico de encaminhar ou não ao psiquiatra.

INTERCONSULTA PSIQUIÁTRICA

A denominação “interconsulta”, no sentido em que é utilizada nesta obra e no Brasil, inclui a consultoria psiquiátrica e a psiquiatria de ligação.

Consultoria refere-se à atuação de um profissional de saúde mental que avalia e indica um tratamento para pacientes que estão sob os cuidados de outros especialistas. A presença do psiquiatra no serviço é episódica, ou seja, responde a uma solicitação específica.

Ligação implica contato, de forma contínua, com serviços do hospital geral, como uma enfermaria de clínica médica ou unidades especializadas em hemodiálise, transplantes e oncologia. O profissional de saúde mental, nesse caso, passa a ser um membro efetivo da equipe médica, participando de reuniões clínicas, atendendo os pacientes e lidando com aspectos da relação estabelecida entre equipe assistencial, paciente e instituição.³⁷

A expressão “interconsulta médico-psicológica”, também comum entre os profissionais da área, foi utilizada por Isaac Luchina, psicanalista argentino, para designar a ação preferencial na relação médico-paciente a partir de um diagnóstico situacional. De acordo com o pensamento desse autor, a interconsulta emerge de um conflito na relação entre médico e paciente, na qual interferem aspectos pessoais, familiares, culturais e institucionais. O manejo desse conflito é a essência da interconsulta médico-psicológica.³⁸

A influência da psicossomática

Os grandes triunfos alcançados no século XIX nos campos da anatomia patológica, da microbiologia e da bioquímica resultaram em uma orientação organicista da medicina, aproximando-a das ciências naturais. Isso aumentou seu grau de especialização e diminuiu a preocupação com aspectos psicossociais do doente. A medicina foi se tornando cada vez mais biomédica, e a psiquiatria foi se restringindo aos grandes manicômios.

No início do século XX, as teorias de Freud, Pavlov e Cannon conduziram ao retorno de uma abordagem psicológica na prática e na pesquisa médicas. Desvendando o sentido inconsciente dos sintomas, ou medindo a importância das emoções no funcionamento biológico, viu-se o desenvolvimento de um modelo psicológico e neurofisiológico de unidade do homem. O termo “psicossomático” foi criado por Heinroth, em 1918, para se referir às influências da mente no corpo e acabou tornando-se consagrado.³⁹

Tendo-se originado na Alemanha e na Áustria, o movimento psicossomático logo floresceu nos Estados Unidos, com vasta produção teórica em torno das relações entre o psíquico, o social e o biológico na determinação da saúde e da doença. Foi um movimento reformista contra a visão reducionista do século XIX, que abordava a saúde e a doença sem levar em conta os atributos que tornam o homem humano.

O movimento psicossomático teve um profundo impacto na prática médica, favorecendo a entrada da psiquiatria no hospital geral. Popularizou-se a expressão “doença psicossomática” – hoje de conceito superado –, que englobava classicamente a úlcera péptica, a asma brônquica, a

hipertensão arterial e a enxaqueca, entre outras afecções nitidamente associadas a fatores emocionais.^{37,39}

As visões das dimensões biológicas, psicológicas e socioculturais, das relações do doente com a família e o meio e, por fim, do significado e do sentido das doenças contribuíram para a moderna concepção de que *toda doença é psicossomática*. No Brasil, Júlio de Mello Filho, que poderia ser considerado o patrono da interconsulta, conseguiu, a partir de um profícuo trabalho no hospital geral, inspirar toda uma geração de psiquiatras.⁴⁰

Há um grande contraste entre as unidades de medicina psicossomática da década de 1940 e os atuais serviços de interconsulta. Naquela época, úlcera duodenal, hipertensão, colite ulcerativa, artrite, hipertireoidismo, neurodermatite e asma, denominadas *Chicago Seven*, estavam entre as categorias nosológicas mais estudadas, particularmente com o enfoque da causalidade psíquica das manifestações somáticas.³⁹

O interconsultor da atualidade passou a estudar a depressão, as tentativas de suicídio, os déficits cognitivos leves e o *delirium*, entre outras manifestações psicopatológicas. Seu enfoque inclui características psicopatológicas, critérios para o diagnóstico, fisiopatologia, fatores de risco, prognóstico, impacto psicossocial da doença, terapêutica farmacológica e psicoterapia de crise. O interconsultor passou a desenvolver instrumental próprio, o que levou ao reconhecimento de uma subespecialidade da psiquiatria.

No início do século XXI, um editorial, cuja leitura é recomendada, destacou alguns dos principais estudos realizados por interconsultores psiquiátricos nas áreas de *delirium*, cardiologia, oncologia e bioética, que foram fundamentais para o aprimoramento da prática médica geral.⁴¹

A preocupação com a efetividade da interconsulta e o gerenciamento financeiro dos gastos na área da saúde fizeram aumentar, nos últimos anos, o número de estudos sobre a relação custo-benefício da interconsulta. Atualmente, há evidências de que alguns serviços de interconsulta psiquiátrica são custo-efetivos e reduzem o tempo de internação, desde que as intervenções sejam realizadas precocemente, e as recomendações do interconsultor, seguidas pela equipe assistencial.⁴²⁻⁴⁵

Ainda que seja difícil a realização de estudos sobre custo-efetividade, a interconsulta psiquiátrica melhora a qualidade da assistência dispensada ao paciente. Há, no entanto, várias dificuldades para definir e mensurar critérios de qualidade de serviço que sejam operacionalmente viáveis.^{43,46} Em síntese, vários problemas metodológicos têm limitado a importância dos achados relacionados à efetividade da interconsulta (Quadro 1.2).

QUADRO 1.2

Problemas metodológicos em estudos de avaliação da efetividade da interconsulta

- Razões institucionais e sociais interferem tanto na decisão de internação quanto no tempo de permanência.
- Em vários estudos, faltam variáveis de controle sobre a gravidade da doença e o número de diagnósticos concomitantes.
- Os estudos só se ocupam da fase de internação, desconsiderando a adesão ao seguimento, a reabilitação e as reinternações.
- Internações tendem a ser por doenças agudas e graves. Isso, aliado a pressões para alta precoce, leva a um “nivelamento por baixo” quando se mede desfecho.
- Alguns estudos focalizam só os casos atendidos pela interconsulta, geralmente mais complexos, com problemas mentais mais graves.
- Não há controle sobre o tempo decorrido entre a internação e a solicitação da interconsulta.

- Dificuldades na definição, na alocação e na avaliação de casos-controle.
- Problemas éticos impedem certos delineamentos de pesquisa.
- Não se sabe até que ponto as recomendações da interconsulta são seguidas.
- Estudos deveriam ser prospectivos, com controle para confundimento e com número suficiente de participantes.
- Necessidade de novas medidas de desfecho: identificação precoce de problemas mentais, custos com exames caros e desnecessários, satisfação de pacientes, familiares e de membros da equipe assistencial, persistência de disfunções, adesão ao tratamento, retorno ao trabalho e reinternações.

Psiquiatria de consultoria e ligação

A psiquiatria que se pratica no hospital geral liga-se a uma especialidade denominada *Consultation-Liaison Psychiatry*, ou, como passou a ser chamada mais recentemente nos Estados Unidos, *Psychosomatic Medicine*. Em Portugal, fala-se em psiquiatria consiliar e de ligação (consiliar, de consílio, no sentido de conselho).

Billings, o criador do termo *Consultation-Liaison Psychiatry*, há mais de 50 anos, já expressava a convicção de que o objetivo principal do trabalho do psiquiatra no hospital geral era melhorar a qualidade da atenção ao paciente, auxiliando na provisão de cuidados a todos os aspectos envolvidos na situação de estar doente e hospitalizado.⁴⁶

A psiquiatria de consultoria e de ligação desenvolveu-se principalmente nos Estados Unidos, a partir da década de 1930, à medida que unidades psiquiátricas foram se estabelecendo em hospitais gerais. Cresceu muito no período pós-guerra, quando os hospitais norte-americanos abrigavam muitos ex-combatentes com transtornos psiquiátricos.^{1,3}

Em 1929, George Henry publicou o primeiro artigo sobre as diretrizes gerais que deveriam nortear o trabalho de consultoria psiquiátrica no hospital geral. Em 1934, Helen Dunbar, uma das pioneiras do movimento psicossomático e criadora da teoria dos perfis psicossomáticos, previa que, em um futuro próximo, psiquiatras seriam requisitados para todas as enfermarias clínicas e cirúrgicas nos hospitais gerais.⁴⁷

Em 1974, o National Institute of Mental Health priorizou a formação de psiquiatras especializados em interconsultas. O estágio nessa atividade durante a residência médica passou a ser obrigatório.⁴⁸ A American Psychiatric Association, em 1992, reconheceu a interconsulta como uma subespecialidade, e, em 2003, a *American Board of Specialties* reconheceu a subespecialidade, sob a denominação de *Psychosomatic Medicine*.⁴⁹

No Brasil, em 1977, no Departamento de Psiquiatria e Psicologia Médica da Escola Paulista de Medicina (atual UNIFESP), teve início o primeiro Serviço de Interconsulta, estruturado e organizado sob a forma de um estágio de treinamento em um programa de Residência Médica em Psiquiatria.⁵⁰

Em muitos desses locais, houve um processo de aproximação, que ilustra como tem-se dado entre nós a migração da psiquiatria dos asilos para o hospital geral. A dinâmica dessa aproximação iniciou-se com a provisão de interconsultas, geralmente conduzidas por alguns profissionais mais entusiasmados com esse tipo de trabalho. Seguiu-se, então, o estabelecimento de outras modalidades de serviço: alguns leitos psiquiátricos provisoriamente instalados em uma enfermaria geral, depois uma unidade de internação, um ambulatório integrado, apoio ao pronto-

socorro, etc. Com o tempo, os serviços de interconsulta e de ligação foram amadurecendo, podendo oferecer assistência de qualidade, ensino e pesquisa.³⁵

A partir da década de 1980, houve um crescimento significativo no campo da interconsulta no Brasil.⁵¹ As primeiras teses acadêmicas na área foram defendidas,^{16,52,53} e livros pioneiros foram publicados.^{4,35,40,54-57} A formação em interconsulta passou a ser recomendada pela Associação Brasileira de Psiquiatria e pela Comissão Nacional de Residência Médica, bem como por outras profissões da área da saúde.⁵⁸

A formação em interconsulta, abordada em apêndice do Capítulo 8, prepara profissionais para trabalharem não somente no âmbito do hospital geral, mas também em atenção primária, postos de saúde ou programas de medicina de família.⁵⁹ O próprio perfil de pacientes atendidos na atenção médica geral, com uma parcela considerável acometida por transtornos psiquiátricos, vem incentivando o reconhecimento do treinamento em interconsulta (Quadro 1.3).

QUADRO 1.3

Realidade sanitária e importância da interconsulta

- Elevada morbidade psiquiátrica em pacientes da atenção primária.
- Aumento da população idosa, com elevação da prevalência de transtornos mentais.
- Aumento da prevalência de condições crônicas (câncer, HIV/aids, hemodiálise, etc.) e de problemas psicossociais e psiquiátricos associados.
- Aumento do custo financeiro e social devido à comorbidade.
- Associação entre estilo de vida e certas doenças.
- Movimento de humanização dos hospitais.
- Valorização da qualidade de vida e da adesão dos pacientes ao tratamento.
- Aspectos emocionais e éticos envolvidos em situações clínicas em que há dilema.

É importante enfatizar, no entanto, que o desenvolvimento da interconsulta inferido a partir de publicações, eventos científicos e serviços universitários está longe de refletir a realidade da psiquiatria em hospitais gerais brasileiros. Na prática, o trabalho como interconsultor em um hospital geral que não esteja vinculado ao ensino se dá mais pelo entusiasmo e pela abnegação de alguns poucos psiquiatras.

Em um levantamento que realizei, observamos que “ganhos financeiros” encontravam-se em último lugar entre as motivações de interconsultores, e “remuneração insuficiente”, entre as principais dificuldades citadas. “Honorários insuficientes” foi uma das razões mais citadas entre os entrevistados que, já tendo trabalhado em interconsulta, haviam desistido de fazê-lo. Não prevista pelo Sistema Único de Saúde (SUS) nem por vários convênios, a interconsulta é desconsiderada e nos obriga a oferecer “amostras grátis” de nosso trabalho, na aposta de que sejam percebidas as vantagens de sua utilização.⁶⁰

Em termos de perspectivas para o futuro, o psiquiatra de consultoria e ligação tem diversas tarefas, notadamente aquelas ligadas ao aprimoramento dos estudos científicos, à melhora das estratégias de intervenção,^{61,62} bem como à extensão de seu campo de ação à atenção primária, além dos muros do hospital geral (Quadro 1.4).

QUADRO 1.4

Tarefas futuras para a psiquiatria de consultoria e ligação

- Ação proativa: participação mais intensa na vida hospitalar.
- Atuação precoce e local em unidades específicas.
- Discussões abarcando aspectos éticos envolvidos no emprego de novas tecnologias.
- Extensão de cuidados além do período de internação.
- Expansão para a atenção primária e o programa da saúde da família.
- Redefinição do papel estratégico de internações em uma UPHG.
- Formação estendida a outros profissionais da saúde.
- Estudos científicos que documentem eficácia e validade das ações.
- Obtenção de recursos para financiar as ações.

O psiquiatra de hospital geral, renovado em sua identidade, está muito mais próximo das ciências biológicas, mas traz, em sua formação, as contribuições da psicanálise, da psicologia social e de outras abordagens psicológicas. A introdução de práticas de saúde mental no hospital geral pode ocasionar uma relação frutífera, mas, ao mesmo tempo, tensa, em que modelos assistenciais podem ser enriquecidos, mas também entrar em conflito, competindo pela hegemonia teórica e prática das ações de saúde.⁶³

Ao se instalar no hospital geral, a psiquiatria corre o risco de ter de se moldar ao modelo médico tradicional – fortemente calcado na objetividade científica e no positivismo –, para ser aceita pela comunidade do hospital. Tal crítica é útil, pois mostra como certos desenvolvimentos na história da assistência psiquiátrica, aceitos de forma geral como progressistas e modernizadores, têm dimensões políticas e ideológicas complexas, que devem também ser consideradas em nossos esforços de historiar e apontar tendências na psiquiatria de hospital geral.⁶⁴

REFERÊNCIAS

1. Bachrach LL. General Hospital Psychiatry: overview from a sociological perspective. *Am J Psychiatry*. 1981;138(7):879-87.
2. Mayou R. The history of general hospital psychiatry. *Br J Psychiatry*. 1989;155:764-76.
3. Greenhill M. Psychiatric units in general hospitals. *Hosp Community Psychiatry*. 1979;30(3):169-82.
4. Botega NJ, Dalgalarrrondo P. Saúde mental no hospital geral: espaço para o psíquico. 2. ed. São Paulo: Hucitec; 1997.
5. Larrobla C, Botega NJ. Las políticas de asistencia psiquiátrica y desinstitucionalización en América del Sur. *Actas Esp Psiquiatr*. 2000;28(1):22-30.
6. Figueiredo G. As origens da assistência psiquiátrica no Brasil: o papel das Santas Casas. *Ver Bras Psiquiatr*. 2000;22(3):133.
7. Perales A, Sogi C, Lolas F. Orientación de la atención psiquiátrica en Sudamérica. Lima: Instituto Nacional de Salud Mental Honório Delgado – Hideyo Noguchi; 1995.
8. Mateus MD, Mari JJ, Delgado PG, Almeida-Filho N, Barrett T, Gerolin J, et al. The mental health system in Brazil: policies and future challenges. *Int J Ment Health Syst*. 2008;2(1):12.
9. Ministério da Saúde (BR). Saúde mental em dados 12. Brasília: MS; 2015.
10. Nascimento AF, Galvanese ATC. Avaliação da estrutura dos centros de atenção psicossocial do município de São Paulo, SP. *Rev Saúde Publica*. 2009;43(Supl. 1):8-15.
11. Pande MNR, Amarante PDC. Desafios para os Centros de Atenção Psicossocial como serviços substitutivos: a nova cronicidade em questão. *Cien Saude Colet*. 2011;16(4):2067-76.
12. Girolamo G, Bassi M, Neri G, Ruggeri M, Santone G, Picardi A. The current state of mental health care in Italy: problems, perspectives, and lessons to learn. *Eur Arch Psychiatry Clin Neurosci*. 2007;257(2):83-91.
13. Alves DSN, Silva PRF, Costa NR. Êxitos e desafios da reforma psiquiátrica no Brasil, 22 anos após a declaração de Caracas. *Medwave*. 2012;12(10):e5545.
14. Thornicroft G, Tansella M. The balanced care model: the case for both hospital and community-based mental health care. *Br J Psychiatry* 2013;202(4):246-8.
15. Sampaio AP. Serviço psiquiátrico do hospital geral de ensino. *Neurobiologia*. 1956;29:72-82.
16. Brasil MAA. A unidade psiquiátrica em hospital geral [dissertação]. Rio de Janeiro: Instituto de Psiquiatria, Universidade Federal do Rio de Janeiro; 1992.
17. Botega NJ, Schechtman A. Censo Nacional de Unidades de Psiquiatria em Hospitais Gerais: I. situação atual e tendências. *Rev ABP-APAL*. 1997;19(3):79-86.
18. Botega NJ. Psychiatric units in Brazilian general hospitals: a growing philanthropic field. *Int J Soc Psychiatry*. 2002;48(2):97-102.

19. World Health Organization. World mental health atlas. Geneva: WHO; 2015.
20. Lucchesi M, Malik AM. Feasibility of general hospitals psychiatric units in Brazil. *Rev Saude Publica*. 2009;43(1):161-8.
21. Larrobla C, Botega NJ. Philanthropic general hospitals: a new setting for psychiatric admissions. *Rev Saude Publica*. 2006;40(6):1042-8.
22. Brasil. Lei nº 10.216, de 6 de abril de 2001. Dispõe sobre a proteção e os direitos das pessoas portadoras de transtornos mentais e redireciona o modelo assistencial em saúde mental. Brasília: Diário Oficial da União; 2001.
23. Candiago RH, da Silva Saraiva S, Gonçalves V, Belmonte-de-Abreu P. Shortage and underutilization of psychiatric beds in southern Brazil: independent data of Brazilian mental health reform. *Soc Psychiatry Psychiatr Epidemiol*. 2011;46(5):425-9.
24. Horta RL, Costa JSD, Balbinot AD, Watted D, Teixeira VA, Poletto S. Hospitalizações psiquiátricas no Rio Grande do Sul de 2000 a 2011. *Rev Bras Epidemiol*. 2015;18(4):918-29.
25. Balbinot AD, Horta RL, Costa JSD, Araújo RB, Poletto S, Teixeira MB. Hospitalizações por uso de drogas não se alteram com uma década de Reforma Psiquiátrica. *Rev Saúde Pública*. 2016;50:26.
26. Ministério da Saúde (BR). Portaria GM/MS nº 3.088, de 23 de dezembro de 2011. Institui a Rede de Atenção Psicossocial para pessoas com sofrimento ou transtorno mental, incluindo aquelas com necessidades decorrentes do uso de crack, álcool e outras drogas, no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS). Brasília: MS; 2011.
27. Botega NJ, Mitsuushi GN, Azevedo RCS, Lima DD, Fanger CP, Mauro MLF, et al. Depression, alcohol use disorders and nicotine dependence among patients at a general hospital. *Rev Bras Psiquiatr*. 2010;32(3):250-6.
28. Botega NJ, de Azevedo RC, Mauro ML, Mitsuushi GN, Fanger PC, Lima DD, Gaspar KC, et al. Factors associated with suicide ideation among medically and surgically hospitalized patients. *Gen Hosp Psychiatry*. 2010;32(4):396-400.
29. Villano LAB. Problemas psicológicos e morbidade psiquiátrica em serviços de saúde não psiquiátricos: o ambulatório de clínica geral [tese]. São Paulo: Escola Paulista de Medicina; 1998.
30. Kerr-Corrêa F, Silva BCM. Avaliação do ensino de psiquiatria pela análise dos pedidos de interconsultas. *J Bras Psiquiatr*. 1985;34:247-52.
31. Millan LR, Miguel Filho EC, Lima MGA de, Fráguas Jr R, Gimenes R. Psiquiatria no hospital geral: experiência de um ano. *Rev Psiquiatr Clín*. 1996;13(1):33-8.
32. Magdaleno Jr. R., Botega NJ. Interconsulta psiquiátrica no hospital geral universitário. *J Bras Psiquiatr*. 1991;40:95-8.
33. Smaira SI, Kerr-Corrêa F, Contel JOB. Psychiatric disorders and psychiatric consultation in a general hospital: a case- control study. *Rev Bras Psiquiatr*. 2003;25(1):18-25.
34. Turato ER. Transtornos mentais em ambulatório. *J Bras Med*. 1985;49(2):116-23.

35. Botega NJ. Consultation-liaison psychiatry in Brazil: psychiatric residency training. *Gen Hosp Psychiatry*. 1992;14(3):186-91.
36. Goldberg DP, Huxley P. *Mental illness in the community*. London: Tavistock; 1980.
37. Lipowski ZJ, Wise TN. History of consultation-liaison psychiatry. In: Wise MG, Rundel JR. *Textbook of consultation-liaison psychiatry*. 2nd ed. Washington: American Psychiatric Publishing; 2002. p. 3-12.
38. Ferrari H, Luchina N, Luchina IL. *La interconsulta médicopsicológica en el marco hospitalario*. Buenos Aires: Nueve Visión; 1977.
39. Wittkover ED. Historical perspective of contemporary psychosomatic medicine. In: Lipowski ZJ. *Psychosomatic medicine*. New York: Oxford University; 1977.
40. Mello Filho J. *Concepção psicossomática: visão atual*. Rio de Janeiro: Tempo Brasileiro; 1979.
41. Kornfeld DS. Consultation-Liaison Psychiatry: contributions to medical practice. *Am J Psychiatry* 2002;159:1964-72.
42. Wood R, Wand AP. The effectiveness of consultation-liaison psychiatry in the general hospital setting: a systematic review. *J Psychosom Res*. 2014;76(3):175-92.
43. Shapiro PA, Lavakumar M. Measures of satisfaction with consultation-liaison services. *Psychosomatics*. 2014;55(3):314.
44. Bujoreanu S, White MT, Gerber B, Ibeziako P. Effect of timing of psychiatry consultation on length of pediatric hospitalization and hospital charges. *Hosp Pediatr*. 2015;5(5):269-75.
45. Wand AP, Wood R, Fossey MJ, Aitken P. Standards, efficiency and effectiveness in consultation-liaison psychiatry. *Aust N Z J Psychiatry*. 2015;49(2):104-5.
46. Strain JJ, Lyons JS, Hammer JS, Fahs M, Lebovits A, Paddison PL, et al. Cost Offset from Psychiatric Consultation-Liaison Intervention with Elderly Hip Fracture Patients. *Am J Psychiatry*. 1991;148(8):1044-9.
47. Lipowski ZJ. Consultation-liaison psychiatry: the first half century. *Gen Hosp Psychiatry*. 1986;8(5):305-15.
48. Cohen-Cole AS, Haggerty J, Raft D. Objectives for residents in consultation psychiatry: recommendations of a task force. *Psychosomatics*. 1982;23(7):699-703.
49. Heinrich TW, Schwartz AC, Zimbrian PC, Wright MT; Academy of Psychosomatic Medicine's Residency Education Subcommittee. The state of the service: a survey of Psychiatry resident education in psychosomatic medicine. *Psychosomatics*. 2013;54(6):560-6.
50. Nogueira-Martins LA, Frenk B. A atuação do profissional de saúde mental no hospital de ensino: a interconsulta medicopsicológica. *Bol Psiquiatr*. 1980;3:30-7.
51. Nogueira-Martins LA, Botega NJ. Interconsulta psiquiátrica no Brasil: desenvolvimentos recentes. *Revista ABP-APAL*. 1988;20(3):105-11.

52. Botega NJ. No hospital geral: lidando com o psíquico, encaminhando ao psiquiatra [tese]. Campinas: Faculdade de Ciências Médicas, Universidade Estadual de Campinas; 1989.
53. Dalgalarrodo P. Repensando a internação psiquiátrica. A proposta das unidades de internação psiquiátrica em hospitais gerais [dissertação]. Campinas: Faculdade de Ciências Médicas, Universidade Estadual de Campinas; 1992.
54. Mello Filho J. Psicossomática hoje. Porto Alegre: Artmed; 1992.
55. Fortes JRA, Miguel Filho EC, Ramadam ZBA, Arruda PV. Psiquiatria e medicina interna. Anais do I Congresso Brasileiro de Psiquiatria e Medicina Interna. São Paulo: Astúrias; 1988.
56. Miguel Filho EC, Ramadam Z B A, Malbegier A, Sousa DG. Interconsulta psiquiátrica no Brasil. São Paulo: Astúrias; 1990.
57. Fráguas Jr. R. Psiquiatria e psicologia no hospital geral: integrando especialidades. São Paulo, Lemos; 1997.
58. Moraes LV. A interconsulta de terapia ocupacional no hospital geral: um espaço para a saúde. Rev Centro de Estudos de Terapia Ocupacional. 2001 6(6):9-13.
59. Park EM, Sockalingam S, Ravindranath D, Aquino PR, Aggarwal R, Nemeroff SF, et al. Psychosomatic medicine training as a bridge to practice: training and professional practice patterns of early career psychosomatic medicine specialists. Psychosomatics. 2015;56(1):52-8.
60. Botega NJ, Guilhermano LG, Michel R, Garcia Jr C, Machado FG, Crestana F, et al. Consultoria psiquiátrica em hospital geral: inviável ou promissora? Rev Bras Psiquitr. 2000;22(3):130-2.
61. Azevedo RC, Mauro ML, Lima DD, Gaspar KC, Silva VF, Botega NJ. General hospital admission as an opportunity for smoking-cessation strategies: a clinical trial in Brazil. Gen Hosp Psychiatry. 2010;32(6):599-606.
62. Camargo AL, Maluf Neto A, Colman FT, Citero VA. Development of psychiatric risk evaluation checklist and routine for nurses in a general hospital: ethnographic qualitative study. Sao Paulo Med J. 2015;133(4):350-7.
63. De Marco MA, organizador. A face humana da medicina: do modelo biomédico ao modelo biopsicossocial. São Paulo: Casa do Psicólogo; 2003.
64. Castel R. A ordem psiquiátrica: a idade de ouro do alienismo. Rio de Janeiro: Graal; 1978.



O paciente diante da doença e da hospitalização

Neury José Botega

O aprofundamento no estudo das condições biológicas, sociais e psíquicas decorrentes da doença e da hospitalização, das condições de estresse e vulnerabilidade, dos traços de personalidade, dos conflitos emocionais e mecanismos adaptativos, bem como das experiências prévias com doenças, médicos e hospitais, deve ser considerada na tentativa de sistematizar uma teoria que, sem ser reducionista ou rotuladora, possa ser de utilidade para os profissionais da saúde.

Este capítulo aborda conhecimentos que ajudam a compreender e a lidar com aspectos psicológicos envolvidos no adoecimento e na internação hospitalar. Especificamente, ocupa-se de mecanismos de defesa, de formas de enfrentar a doença (*coping*) e de traços de personalidade que influenciam a reação das pessoas à doença e à hospitalização.

Fiz um trato com meu corpo.

Nunca fique doente.

Quando você quiser morrer,

Eu deixo.

Paulo Leminski.¹

Na poesia, o autor parece tranquilo. Declara, taxativamente, que um acordo já foi estabelecido. Seu corpo permanece cativo e obediente a um *eu* muito poderoso. Entre as possibilidades da vida, a doença que chega sem aviso foi afastada, e a morte acontecerá sem sofrimento, com autorização. Portanto, problema resolvido; não é preciso mais se angustiar diante de duas grandes incertezas: a doença e a morte.¹

Quando nosso corpo está em silêncio, comumente nos esquecemos dele. Parece tão “nosso”, algo garantido que nos pertence. Tomamos por pressuposto que se submeterá a nossos desejos e obedecerá a nossas ordens. No íntimo de nossa mente, nosso corpo também tem outra característica descolada da realidade do ser: é imortal.

Quanto à doença, ela serve para nos lembrar de que temos corpo, podemos morrer. E é ele – nosso corpo – que pode nos matar. É interessante que, nessa circunstância, o corpo pode ser transformado em principal inimigo, ou mesmo levar a culpa por não ter reagido à ameaça de doença.

O sentimento de uma pessoa que, de repente, se vê gravemente enferma é de que, a partir de seu próprio corpo, deixou de ser dona de si. Imaginemos, por exemplo, alguém que, em decorrência de um acidente vascular cerebral, deixou de movimentar braço e perna. Tal pessoa antes pensava “levante-se” e via seu corpo se levantar; ordenava “ande!”, e seu corpo andava... Com as limitações da doença, passa a se sujeitar ao corpo, e a ele tem de perguntar: “posso...?”.

A vivência é de se tornar escravo do corpo e do tempo. A doença traz essa vivência pungente de quebra de uma linha de continuidade da vida, das funções desempenhadas no dia a dia, de certa previsibilidade que guardamos sobre o dia de amanhã.

O impacto da doença imobiliza e congela a existência e, em consequência, nossa relação com o mundo. Há uma interrupção da continuidade existencial e da referência temporal. É um tempo de suspensão; difícil ligá-lo à vida passada ou conectá-lo ao futuro. As preocupações mais imediatas passam a girar em torno do estado corporal e da passagem das horas.

Essa condição fora enfatizada por Freud, em 1914:²

É do conhecimento de todos, e eu o aceito como normal, que uma pessoa atormentada por dor e mal-estar orgânico deixa de se interessar pelas coisas do mundo externo, na medida em que não dizem respeito a seu sofrimento. Uma observação mais detida também nos ensina que ela também retira o interesse libidinal de seus objetos amorosos: enquanto sofre, deixa de amar. [...] Devemos, então, dizer: o homem enfermo retira suas catexias libidinais de volta para seu próprio ego, e as põe para fora novamente quando se recupera.

A enfermidade transforma o homem sujeito de intenções em sujeito de atenção.³ A internação em um hospital amplia o impacto psicossocial dessa condição de vida. Strain⁴ postula oito categorias de estresse psicológico a que está submetido o paciente hospitalizado por uma doença aguda, tendo por base as fases psicodinâmicas do desenvolvimento:

1. **Ameaça básica à integridade narcísica.** São atingidas as fantasias onipotentes de imortalidade, de controle sobre o próprio destino e de um corpo indestrutível. Podem emergir fantasias catastróficas, com sensação de pânico, aniquilamento e impotência.
2. **Ansiedade de separação,** não só de pessoas significativas, mas de objetos, ambiente e estilo de vida.
3. **Medo de estranhos.** Ao entrar no hospital, o paciente coloca sua vida e seu corpo nas mãos de pessoas desconhecidas, cuja competência e intenção ele desconhece.
4. **Culpa e medo de retaliação.** Ideias de que a doença veio como um castigo por pecados e omissões, fantasias de destruição de uma parte enferma do corpo, “traidora”.
5. **Medo da perda do controle** de funções adquiridas durante o desenvolvimento, como a fala, o controle dos esfíncteres, a marcha, etc.
6. **Perda de amor e de aprovação,** com sentimentos de autodesvalorização gerados pela dependência, sobrecarga financeira, etc.
7. **Medo de dano a partes do corpo.** Mutilações ou disfunções de membros e de órgãos alteram o esquema corporal.
8. **Medo da dor e da morte.**

Não há outra forma de se inteirar de quais temores e sentimentos mais afligem o paciente, bem como do significado e das implicações que o adoecimento traz, a não ser ouvindo-o com disponibilidade de tempo, com respeito às ideias e aos sentimentos a nós expressados. Adota-se uma postura que procura conhecer, sem crítica, a *pessoa* que se encontra doente. Chama-se isso de *escuta ativa* (Quadro 2.1), e, sobre esse assunto, nos aprofundamos no Capítulo 26.

QUADRO 2.1

Principais características da escuta ativa

- Proporcionar ambiente físico de acolhimento (privacidade, conforto, proximidade interpessoal adequada).
- Atitude de respeito e interesse, sem criticar.

- Manter contato visual frequente.
- Iniciar com perguntas gerais e menos constrangedoras (identificação, razão da consulta).
- Preferir perguntas abertas (usar “como...?” , “Eu posso imaginar...”, em vez de “Por que...?”).
- Compreensão de conteúdo e conotação da mensagem (postura, gestos, tom de voz).
- Observar reações emocionais do paciente, pontuando-as, quando pertinente.
- Resumir o que entendeu até dado momento e solicitar algum esclarecimento.
- Respeitar momentos de silêncio e de choro, mas ajudar, com delicadeza, o paciente a sair deles.

Para algumas pessoas, a doença pode ser vivenciada como um abalo que se impõe ao sujeito, com desabamento do narcisismo, da onipotência e dos arranjos provisórios mantidos para “ir levando a vida”. As reações e o humor podem oscilar entre extremos: da tristeza e do desamparo à revolta e ao desespero. Há momentos angustiantes de vazio e de não compreensão. A vivência é de catástrofe.

No Capítulo 26, lembramos ao médico que, antes mesmo de conseguir compreender, é preciso suportar o não compreender. A catástrofe – desencadeada pela doença aguda e internação hospitalar – costuma solapar do paciente a capacidade de organizar as ideias e de reagir à sensação de desabamento existencial. Quando o desespero encontrar os primeiros pensamentos e palavras, o médico continuará ali, ao lado do paciente, com mais chance de compreender, junto com ele, o desenrolar da crise imposta pelo adoecimento.

Contrastando com essa vivência de catástrofe, a primeira reação de algumas pessoas diante do diagnóstico de uma condição clínica grave é de anestesia. Pode advir um comportamento de aparente alegria e frescor existencial, que chamamos de “fuga para a saúde”. Em personalidades mais egocêntricas, a doença pode abalar a autoestima a ponto de se transformar em ferida narcísica. Isso costuma acrescentar dificuldades na interação com a equipe assistencial. É do que se ocupa o Capítulo 4, Pacientes-problema: um impasse.

Algumas pessoas acostumadas a manter rigidamente o controle de diversos aspectos de suas vidas poderão se relacionar exasperadamente com seus cuidadores. Não abrem mão de uma posição de comando, exigindo, a todo momento, que se atendam suas inúmeras solicitações.

Outras têm seus traços de instabilidade e incontinência emocionais exacerbados e demandam, de parte da equipe assistencial, mais atenção do que o normal. Não raramente, esses pacientes provocam raiva e esgotamento. O profissional da saúde poderá, nesses casos, se sentir explorado, controlado, e responder com hostilidade, o que não é aconselhável. Apenas enredou-se na trama emocional do paciente.

O que descrevemos até aqui são facetas dos vários significados que o adoecimento pode ter para cada um de nós. O Quadro 2.2 lista possíveis representações da doença para o sujeito.

QUADRO 2.2

Algumas significações subjetivas desencadeadas no paciente pela díade doença-internação

Catástrofe

Desafio

Tragédia

Valor

Descontrole

Provação

Descanso

Oportunidade estratégica*

Expição

Castigo

Álibi

Inimigo externo

Inimigo interno

Derrota

Fraqueza

* para ganhos financeiros, regressão psicológica, acerto de contas com o passado, com os outros e com os próprios fantasmas

TRANSFERÊNCIA E CONTRATRANSFERÊNCIA

No encontro terapêutico, à semelhança da relação entre pai e filho durante a infância, o médico passa a ser o depositário de fantasias repletas de elementos mágicos que configuram a transferência. Esse conceito nasceu da psicanálise. A criança assustada, que o paciente pode trazer secretamente dentro de si, espera reencontrar no médico a capacidade materna de aplacar a angústia e a dor, de acolher fantasias aterrorizantes desencadeadas pela doença e devolvê-las transformadas, elaboradas e mais aceitáveis.

Outras vezes, espera-se encontrar no médico alguém que se assemelhe à imago paterna, investida de força e habilidade, dotada de poderes mágicos capazes de controlar e domar os perigos.^{5,6}

A contratransferência compreende, para alguns, tudo o que, da personalidade do profissional, pode interferir no tratamento. Outros limitam o conceito aos processos inconscientes que a transferência do analisando provoca no analista.⁷ Assim, o inconsciente do analista entenderia o de seu paciente. Essa relação nasce em nível profundo e aparece na superfície sob forma de sentimentos em resposta ao paciente.⁸

A contratransferência é um fenômeno normal, em uma convergência e integração dos campos intrapsíquico e interpessoal. Não se refere a uma percepção em sentido estrito, e sim a um indício de grande significado semiológico. Quando conscientizada e controlada, ela auxilia o trabalho terapêutico em zonas mais obscuras do paciente e de suas relações.⁹

REAÇÃO DE AJUSTAMENTO

Pacientes reagem diferentemente às doenças e à internação hospitalar. São vários os fatores que determinam respostas individuais a essas condições. O significado pessoal e subjetivo que a doença física desperta parece ser o fator fundamental, modulado por características de personalidade, circunstâncias sociais e pela própria natureza da patologia e de seu tratamento.

Demora um tempo para que, após a fase de diagnóstico e terapêutica inicial, a pessoa se acalme e, ao longo de um tempo variável, se recomponha e amplie seus interesses, voltando a ter ânimo e a planejar o futuro. Em outras palavras, veem-se aqui as mesmas fases observadas em um processo de *luto*: após o impacto da doença e da hospitalização, espera-se que a pessoa vá retomando a esperança e o comando de sua vida (ainda que isso possa ocorrer, inicialmente, apenas na esfera mental, com o controle do pessimismo e das fortes reações emocionais).

As ameaças e frustrações que acompanham o adoecer podem ser intensas. A doença passa a ser a marca da impotência, transformando-se em uma ferida psíquica que não cicatriza, ainda que, de fato, as coisas estejam dando sinais de melhora. Algumas pessoas têm seu sofrimento prolongado, pois não conseguem elaborar (“digerir”) a situação de perda.

As reações de ajustamento são frequentes entre pacientes internados no hospital geral. Entre os internados em uma enfermaria de clínica médica do Hospital das Clínicas da Unicamp, 39% apresentam sintomas de ansiedade e/ou depressão em uma intensidade que requer atenção específica. A exemplo do observado na atenção primária, o padrão mais comum de sintomas é de natureza indiferenciada, compreendendo uma combinação de preocupações excessivas, ansiedade, depressão e insônia. Em um quarto dos casos, as dificuldades observadas associam-se a problemas duradouros nas áreas emocional e social.¹⁰

Na prática clínica, as reações de ajustamento podem ser tomadas como uma síndrome parcial de um transtorno específico do humor, a meio caminho entre o comportamento normal e um transtorno psiquiátrico de maior gravidade. O início costuma ocorrer dentro de um mês do evento estressante, e a duração dos sintomas não costuma durar mais do que seis meses. O diagnóstico depende de uma cuidadosa avaliação da relação entre forma, conteúdo e gravidade dos sintomas, tipo de evento estressante, personalidade e história de vida.

No caso de doenças agudas, como infarto do miocárdio, os sintomas desenvolvem-se dentro de dois ou três dias. A ansiedade surge primeiro, sobretudo quando não se tem certeza do diagnóstico e da evolução do quadro clínico. Sintomas depressivos aparecem posteriormente e podem durar semanas. Em geral, os sintomas são transitórios, melhoram com apoio psicológico e boa comunicação e costumam ceder com a recuperação clínica e a alta hospitalar.

No tratamento das reações de ajustamento, psicotrópicos e psicoterapia conduzida por especialista são raramente necessários. Isso não significa que a detecção e a abordagem dos sintomas possam ser dispensadas. Reações de ajustamento exigirão mais tempo dedicado para ouvir o paciente, inteirar-se de suas dúvidas e temores, em uma atitude de respeito às suas aflições. Em quadros sintomatológicos mais graves e prolongados, ou em casos de dificuldade no diagnóstico e no manejo do paciente, a avaliação psiquiátrica é aconselhável.

Em alguns casos, os sintomas são mais graves e persistem por mais tempo. Comumente são de natureza depressiva, atingindo níveis de gravidade compatíveis com critérios diagnósticos para episódio depressivo. No momento da avaliação do paciente, sintomas como perda do interesse, anedonia (falta de prazer em atividades antes prazerosas) e desesperança devem ser ativamente pesquisados. O Capítulo 15, sobre depressão em pacientes clínicos e cirúrgicos, aprofunda-se nesse aspecto.

Sabe-se que uma parcela significativa dos pacientes detectados com episódio depressivo maior no início de uma internação em hospital geral continuará deprimida à época da alta e vários meses após ter deixado o hospital.¹¹ Em um estudo realizado no HC Unicamp, a reavaliação, após seis meses da alta hospitalar, de 50 casos de episódio depressivo diagnosticado durante a internação mostrou que dois terços continuavam deprimidos. Apenas uma minoria (um terço do total) havia recebido tratamento para depressão na rede pública de saúde.¹²

MECANISMOS DE DEFESA

Os mecanismos psicológicos de adaptação à doença e à hospitalização podem ser estudados sob as vertentes psicodinâmica (mecanismos de defesa, modalidades de apego, personalidade), fisiológica (estresse) e cognitiva (*locus* de controle, *coping*). O tópico sobre modalidades de apego é abordado no Capítulo 4. Aconselhamos sua leitura, pois traz subsídios importantes para a compreensão das reações diante do adoecimento e da internação hospitalar.

Ao atendermos os pacientes, ouvimos seus relatos, observamos comportamentos e intuimos suas vivências. Defesas psicológicas, propriamente, são algo que inferimos. A ideia de mecanismos de defesa do ego ocorreu a Freud quando ele se deu conta da resistência que seus pacientes manifestavam contra representações inconciliáveis (“conteúdos penosos”) que chegavam à consciência.

Essa atitude defensiva da mente foi reconhecida como o mecanismo principal na etiologia da histeria. O que o ego teme é algo da “natureza de uma destruição ou extinção”, segundo Freud.² Procurará, então, proteger-se de perigos internos e externos, de forma mais ou menos madura (como na sublimação e na regressão, respectivamente). Vários mecanismos de defesa foram estudados com mais profundidade por sua filha, Anna Freud:¹³ recalcamiento, regressão, formação reativa, isolamento, anulação retroativa, projeção, introjeção, retorno sobre si mesmo, reinversão da pulsão, sublimação, negação, idealização, identificação com o agressor.

Os mecanismos de defesa não são inteiramente obra do ego, alguns deles ocorrendo antes mesmo da conformação egoica. Essa ideia foi aventada por Freud e mais trabalhada por Melanie Klein, com as noções de clivagem do objeto, identificação projetiva, negação da realidade e controle onipotente.¹⁴ Esses mecanismos, conhecidos como “primitivos”, surgem mais precocemente no desenvolvimento psíquico e são observados até mesmo em bebês. Ganham relevância, por exemplo, entre pacientes com transtorno da personalidade *borderline* (ver Cap. 4). Embora primitivos, podem se manifestar no homem até então saudável, dependendo de sua personalidade e do impacto de certos acontecimentos.

Inicialmente descritos como defensivos, mecanismos psicológicos de defesa são essenciais na própria constituição do sujeito, de sua personalidade, capazes de proporcionar uma espécie de viabilidade mental na relação do indivíduo com a realidade, incluindo-se sua realidade mais íntima, às vezes apenas “sentida” e desprovida de representações mentais.⁷

Consolidou-se a noção de que mecanismos de defesa dão subsídios importantes para a compreensão do comportamento humano, incluindo as reações diante da doença e da hospitalização. Com o tempo, ampliaram-se as descrições de mecanismos de defesa, com modalidades que se avizinham e que usam tanto o referencial psicodinâmico quanto o cognitivo-comportamental.

Negação

Por meio da negação, o paciente passa a agir como se não estivesse sob ameaça. É um recurso para evitar sofrimento, medo e desespero. Pode postergar ou abandonar o tratamento,

desacreditar os resultados de exames, agir como se nada de grave estivesse acontecendo ou tentar fazer crer que seu problema clínico é de natureza mais branda do que todos estão pensando. Outras vezes, observa-se uma pessoa que, embora submetida a procedimentos invasivos e dolorosos, não faz perguntas sobre a razão de sua internação ou dos remédios que está tomando.

De certa forma, a racionalização, outro mecanismo de defesa bastante observado na clínica, apoia-se na negação e no isolamento de sentimentos penosos. O paciente poderá querer conversar, às vezes até animadamente, sobre os aspectos técnicos de seu diagnóstico e tratamento. Outra forma de negar conflitos e sentimentos é a banalização. Dá-se a um problema grave apenas alguma importância, o assunto logo é mudado, ou segue-se uma brincadeira. O paciente, de modo estranho e fora do que o médico em geral esperaria, parece pouco impressionado com seu estado de saúde.

Características como as descritas podem constituir traços de caráter mais ou menos integrados à personalidade. São sintomáticas, no entanto, quando parecem, aos olhos do examinador, rígidas e forçadas.

Essas posturas de defesa precisam ser respeitadas. Significam, afinal, a impossibilidade de suportar a carga emocional advinda da situação de doença. Para muitos pacientes, certo grau de negação é um mecanismo útil para enfrentar a ansiedade despertada por doença e cirurgia iminente. Esse comportamento é considerado, por alguns autores, um fator de proteção entre pacientes internados em unidades coronarianas.¹⁵ Quando elas impedem o bom curso do tratamento, aí sim precisam ser abordadas, em uma tentativa de enfraquecê-las.

É preciso respeitar o tempo interno do paciente, e não o forçar a encarar verdades.¹⁶ Arrombar-lhe as portas e janelas do ego, impondo a realidade dos fatos, é uma atitude violenta. Tal conduta responde mais à angústia e ao despreparo do médico. Não tem a ver com necessidade de franqueza e de eficiência na tarefa médica.

As clássicas perguntas que um clínico pode se fazer são: “revelar ou não o diagnóstico?”, “quando?”, “como falar?”, e devem ser respondidas após parar para ouvir um pouco mais o paciente, prestando atenção em sua linguagem verbal e não verbal, até que possa intuir sobre o que ele deseja e suporta saber. Poderá, então, com mais tranquilidade, decidir-se sobre o que, como e quando falar.

São comuns situações nas quais a negação de um diagnóstico foi compactuada entre médico e familiares, que decidiram não comunicar algo penoso, mesmo quando o paciente se encontra em plenas condições mentais de lidar com os sentimentos que tal revelação provocaria. A observação, no paciente, de instabilidade afetiva, com crises de choro, irritabilidade, insônia, bem como demanda exagerada e desnecessária de atenção, pode indicar a falha do mecanismo de negação, um sinal de que a pessoa já pode, e necessita, abrir-se com alguém.

Regressão

O impacto psicológico da doença, aliado às próprias condições de uma internação, na qual o paciente recebe cuidados básicos de higiene, alimentação e medicação, favorece o mecanismo de regressão. A atualização de um modo de funcionamento ligado a etapas mais precoces do

desenvolvimento permite satisfações de necessidades afetivas primitivas. Além disso, o paciente pode adotar uma posição muito passiva, não demonstrar força para reagir, regredindo em seu comportamento e suas necessidades, chegando, às vezes, a fases não verbais e não motoras.

A regressão nada tem de anormal em uma situação grave e aguda, na qual o paciente tem de se colocar nas mãos da equipe médica e se deixar cuidar. Aliás, a incapacidade de se entregar a certo grau de regressão, forçando-se a uma perfeita adaptação à doença, pode, com o tempo, ser prejudicial. Quando se prolonga no decorrer do tratamento, a regressão aumenta desnecessariamente a permanência no leito, incentiva a dependência e retarda a convalescença, podendo chegar ao hospitalismo. Tal comportamento impede o paciente de usar recursos pessoais mais maduros para enfrentar as dificuldades presentes, imprimindo a ideia de que participação mais ativa no tratamento implicará maior sofrimento.

A regressão é favorecida pela situação real de dependência na qual a pessoa se encontra e pela atitude dos familiares e da equipe assistencial, quando passam a tratar o paciente como criança. Essa modalidade de relação, quando preponderante, poderá reforçar a regressão, passando para o paciente a impressão de que o julgam realmente incapaz. Uma impressão de que não adianta se esforçar, pois não conseguirá.

A atitude oposta (“Vamos lá! Só depende de você!”) é igualmente inadequada. Imagine como se sente uma pessoa acamada e deprimida, sem motivação, ao ouvir alguém dizer que “só depende dela”. Provavelmente, vai se sentir mais incapaz, mais só, sem apoio e sem compreensão. É preciso tratar a pessoa adoentada com delicadeza, mas sem infantilizá-la. O paciente necessita de “gotas de otimismo”, não de uma ordem quase eufórica e condenatória.

A esse respeito, é ilustrativo o trecho de uma entrevista dada por Federico Fellini no hospital, após ter sofrido um acidente vascular cerebral e passado duas semanas em coma. Perceba como ele repara de forma tão aguda quanto mordaz alguns dos principais cacoetes de profissionais da saúde e o efeito que isso produz nele:

Durante meses, você é inserido em lugares aparentemente protetores, com hierarquias, histeria e acessos de raiva que não são seus, num vórtice de dias que não são seus. Você é tratado como um jogador de futebol: “Vamos lá, não desista. Você tem que conseguir. Onde está sua coragem? Você precisa cooperar, vamos lá...”. Ou então como se fosse um bebê: “Agora eu quero que você venha e pegue este lápis com sua mão esquerda...”. E você não consegue nem sequer fazer isso. [...] Você é mergulhado num ambiente infantil, de berçário. “Agora vamos lavar nosso rosto. Será que queremos um pouco de queijo em nossa sopinha? Agora vamos tomar nosso comprimido, nosso comprimido para dormir, nosso tranquilizante.” Mas o único “eu” nesse “nós”, o único que é obrigado a lutar e sofrer, é você mesmo. A doença torna você dependente. Essa dependência faz você regredir à infância.¹⁷

Deslocamento

Em algum momento no curso do tratamento, o paciente poderá deslocar sua raiva contra um familiar ou contra a equipe médica, culpá-los pela doença ou por algum acontecimento, tentando aplacar a angústia e a revolta que não consegue conter. Geralmente, essa reação é passageira, correspondendo a uma fase em que o paciente se encontra sob o impacto de um diagnóstico ou de alguma notícia adversa.

Em um estágio posterior, à medida que for aceitando sua condição, o paciente poderá mostrar-se mais triste, rememorando passagens de sua vida, tentando compreender e aceitar seu destino e, pelo menos nos casos em que não houver um prognóstico sombrio, planejando sua vida após a alta.

A atitude do paciente enraivecido por sua condição de doença e de dependência poderá ser de arrogância e desprezo ou exigirá tal nível de dedicação que afastará as pessoas dele. A equipe assistencial passará a colocá-lo “no gelo” ou mesmo, de alguma maneira, agredi-lo de forma sádica (ainda que passivamente). Deve-se lembrar que, em casos como esse, costuma haver um processo de “contaminação”, no qual os sentimentos do paciente, principalmente suas necessidades mais primitivas, podem influenciar e modificar o modo de as pessoas agirem em relação a ele.

PERSONALIDADE, ESTRESSE E COPING

A personalidade pode ser compreendida como resultante da combinação de propensão biológica, experiências vivenciadas ao longo da vida e contexto sociocultural. Ela é relativamente estável ao longo da vida da pessoa, ainda que sujeita a mudanças dependentes de experiências existenciais marcantes ou de alterações neurobiológicas.

A personalidade tem caráter preditivo, na medida em que é um conjunto probabilístico de respostas cognitivas, afetivas e comportamentais a acontecimentos da vida. A resposta a esses acontecimentos, por exemplo, no momento que surge uma doença liga-se a experiências semelhantes vividas no passado.¹⁸

Foram descritos vários tipos de personalidade, sempre colocados em uma classificação ou listagem. Hipócrates explicava os tipos humanos pelo predomínio de um dos quatro humores constitutivos: sanguíneo (sangue), fleumático (fleuma – ou linfa), colérico (bílis) e melancólico (bílis negra). A tipologia junguiana refere-se a duas variações básicas: introversão e extroversão. Os biotipos de Kretschmer associavam-se a características específicas de personalidade: longilíneo (ou leptossômico), brevilíneo (ou pícnico) e atlético (muscular). Atualmente, predominam estudos empíricos, fortemente calcados na psicometria. Procuram-se dimensões que, combinadas, possam caracterizar diferentes personalidades.^{18,19}

São mais conhecidos e estudados o modelo dos cinco fatores (*big five*)²⁰ e o dos três fatores de Cloninger²¹ (Quadro 2.3).

QUADRO 2.3

Dois famosos modelos de personalidade

Hipócrates	Três fatores	Cinco fatores*
Sanguíneo Face rosada, porte atlético, musculatura firme Expansivo, otimista Irritável, impulsivo Submetido aos instintos	Procura por novidade Excitação e exaltação por estímulos novos, que são sempre buscados e que propiciam gratificação e alívio da monotonia. Impulsividade, inconstância nos interesses e nas amizades. Ativação da neurotransmissão dopaminérgica. Associação a abuso de substâncias psicoativas e a comportamentos sociopáticos.	Neuroticismo Tendência a afetos negativos (ansiedade, depressão). Tensão, preocupação, autopiedade. Impulsividade, pensamentos hostis ou raivosos
Fleumático Face pálida, formas arredondadas Olhar doce e vago Sonhador, pacífico Existência isenta de paixões	Evitação de danos Resposta intensa a estímulos aversivos. Temeroso, antecipa os perigos. Pessimismo, inibição. Preferência pelo familiar e previsível. Ativação serotoninérgica.	Extroversão Atividade, energia, entusiasmo. Tendência a ser falante, a buscar companhia, assertividade.
Colérico Protuberâncias musculares evidentes Olhar ardente Ambicioso, dominador, tenaz Reações abruptas e explosivas	Dependência de recompensa Resposta a sinais de recompensa (principalmente de aprovação social). Busca de apoio emocional nos outros, responsivos a pressão social. Sensibilidade à rejeição. Ativação noradrenérgica.	Abertura Curiosidade, imaginação, originalidade. Tendência à arte. Maior capacidade de <i>insight</i> .
Melancólico Olhar triste e músculos pouco desenvolvidos Nervoso, excitável Tendência a pessimismo, rancor e solidão		Amabilidade Gentileza, generosidade, empatia. Inspira confiança. Compaixão.
		Conscienciosidade Organização, eficiência, responsabilidade. Ambição. Planejamento.

* Os fatores são dimensionais. Uma baixa pontuação em Extroversão, por exemplo, significa que o indivíduo tende a ser introvertido. Baixa pontuação em Amabilidade significa estilo agressivo e antagonista, rudeza.

Fonte: Ursano e colaboradores¹⁸ e Dalgalarrodo.¹⁹

O modelo dos cinco fatores de personalidade foi derivado de uma análise fatorial de aproximadamente 18 mil adjetivos da língua inglesa empregados para descrever características de personalidade.²² O modelo dos três fatores (de Cloninger) baseia-se mais fortemente em temperamentos básicos do que em dinâmicas interpessoais. Procura integrar os principais sistemas de neurotransmissão (dopaminérgico, serotoninérgico e noradrenérgico) com uma descrição tridimensional de traços de personalidade.²¹

Na prática, o psiquiatra interconsultor costuma estar mais interessado em identificar e manejar padrões de reações que impedem o bom andamento do processo diagnóstico e do tratamento. Nem sempre é possível, de maneira mais aprofundada, traçar um perfil de personalidade dos pacientes internados.

As estratégias utilizadas no manejo do paciente baseiam-se tanto no referencial dos mecanismos de defesa e de *coping* quanto nos traços predominantes da personalidade (Quadro 2.4).

QUADRO 2.4

Traços de personalidade, com suas características, forma de conceber a doença e sugestões de manejo

Traços de personalidade	Características	Significado da doença	Manejo
Dependente	Necessidade de atenção Demandas urgentes Requer tratamento especial Busca de apoio	Risco de abandono, com sentimento de desamparo	Expressar boa vontade Explicar limitações reais Pequenas concessões
Obsessiva	Ordem excessiva Detalhismo Rigidez Medo do imprevisto	Ameaça devido à perda de controle	Informar cuidadosamente Permitir participação em tomadas de decisões
Histriônica	Excessiva familiaridade Sedução Dramatização Rejeição	Visão catastrófica Ataque frontal à identidade	Apreciar qualidades reais e coragem diante da doença Dar oportunidade para expressar temores
Masoquista	Sacrificado Sofredor contínuo Sentimentos de não ser querido Hostilidade se sofrimento for desvalorizado	Castigo merecido	Reconhecer e ponderar seu sofrimento Seu tratamento também é uma ajuda aos demais
Paranoide	Desconfiado Cauteloso Hipersensível	Um ataque exterior, com risco de provocar dano ou traição	Informar minuciosamente diagnóstico e tratamento Ouvir com atenção suas queixas
Narcisista	Incapaz de aceitar ajuda Aparente fortaleza Inteirado de tudo Orgulhoso	Ataque à perfeição e à onipotência (“ferida narcísica”)	Reconhecer e ponderar sua resistência Tomá-lo participante Diminuir sensação de enfermo = fraco
Esquizoide	Distante e frio Introvertido e reservado Mínimo contato social Não ligado a tarefas cotidianas	Intrusão, perda da privacidade, ser forçado ao contato	Respeitar seu isolamento Atitude cuidadosamente não intrusiva

Certas descrições clássicas de perfil de personalidade não se encaixam ao que está concisamente descrito nos Quadros 2.3 e 2.4 nem se encontram associadas a transtornos da personalidade do Manual diagnóstico e estatístico de transtornos mentais (DSM-5) ou da

Classificação internacional de doenças e problemas relacionados à saúde (CID-10). A chamada personalidade tipo A²³ é um clássico da medicina psicossomática e se encontra descrita no Quadro 2.5.

QUADRO 2.5

Personalidade tipo A

A personalidade tipo A engloba um padrão comportamental que inclui ambição, competitividade, agressividade, impaciência, tensão muscular, constante estado de alerta, modo rápido e empático de falar, cinismo, hostilidade, raiva e necessidade de controlar o ambiente. Esse perfil é mais frequentemente encontrado em pessoas exageradamente dedicadas ao trabalho (*workaholics*). Esse padrão comportamental associa-se fortemente a doença arterial coronariana. Um infarto agudo do miocárdio e a consequente necessidade de internação em uma unidade coronariana podem levar a pessoa a comportamento hostil e crises de raiva. Ela pode sentir-se derrotada pela doença (perda da autonomia) e humilhada perante a equipe assistencial (dificuldade de aceitar posição de dependência).

Facilitar a expressão do paciente, ser respeitoso, prover as informações solicitadas sobre seu estado de saúde e tratamento, assegurar que tudo está sendo feito para apressar seu restabelecimento, permitir que ele tome algumas decisões em relação à rotina de cuidados, envolvê-lo ativamente em um plano de recuperação, tudo isso poderá ser de muito auxílio. As informações e a concessão de algumas prerrogativas ajudam o paciente a readquirir um senso de autonomia e de controle. Isso deverá reduzir sua ansiedade e aumentar a cooperação com a equipe assistencial.

Fonte: Rosenman.²³

A noção de estresse veio da física, referindo-se ao grau de deformidade que uma estrutura sofre quando é submetida a um esforço. Ela chegou à medicina relacionada às reações adaptativas de um organismo vivo quando submetido a agentes nocivos (dor, frio, fome, estados tóxicos e infecciosos).

Em psicologia, o estresse é relacionado ao cumprimento de tarefas de responsabilidade, a reações a eventos inesperados e a situações de expectativa e de contato com o novo.²⁴

O homem reage não só a um perigo real e atual, mas também a ameaças de perigo (potenciais ou imaginadas) relativas tanto a situações pessoais como a condições de um ambiente inseguro, criado por nosso sistema social e econômico. O que determina a patologia é a reação do organismo, e, com muita frequência, a gravidade da enfermidade deve-se, primariamente, à violência dos mecanismos de defesa orgânicos. O estresse prolongado afeta o sistema imunológico do organismo e suas defesas naturais contra infecções e outras doenças.

Tal como a maioria dos animais, reagimos a qualquer espécie de desafio mobilizando nosso organismo, em preparação para a luta física ou para a fuga; mas, na maioria dos casos, essas reações deixaram de ser úteis [...]. Sendo civilizados, tentamos enfrentar o desafio de um modo socialmente aceitável, mas as partes “velhas” de nosso cérebro continuam mobilizando o organismo para respostas físicas inadequadas. Se isso acontecer repetidas vezes, nós provavelmente adoeceremos.²⁵

Há muitos elos desconhecidos na cadeia de eventos iniciada por acontecimentos que têm um caráter simbólico, provocando respostas psicológicas, chegando a alterações fisiológicas. Ainda assim, o conhecimento dos fatores que contribuem para intensificar ou minorar o estresse pode propiciar a elaboração de estratégias a serem utilizadas em tratamentos individuais ou coletivos, de caráter preventivo. Esses fatores dependem de:²⁶

- Personalidade (dados biográficos e contextuais)

- Forma como algo é percebido e avaliado (crenças, expectativas, sentimentos)
- Desenvolvimento e evolução dos sintomas e da conduta problemática
- Magnitude, intensidade, frequência, duração e previsibilidade de um evento
- Experiência anterior do indivíduo com situações semelhantes
- Fatores socioculturais (imagem da doença, rede de apoio social)
- Motivação para a mudança de atitude

De acordo com modelos cognitivos do comportamento, as pessoas podem ser divididas em duas grandes categorias quanto à maneira como enfrentam as adversidades orientadas para a solução do problema ou orientadas para a emoção.

As pessoas cujo *coping* é orientado para a solução de problemas, ao lidarem com situações de doença, tendem a buscar informações, procuram trocar ideias com médicos, amigos, grupos de autoajuda, a fim de alterar suas concepções, seus hábitos, bem como as características do ambiente em que vivem. Tudo isso com a finalidade de reassumir o controle de suas vidas, tornando as consequências da doença mais toleráveis.

As pessoas com *coping* orientado para a emoção estão mais preocupadas em lidar com suas emoções, reduzindo-lhes o impacto. Elas têm mais dificuldades para se focalizar em alternativas cognitivas. Esses pacientes respondem mais emocionalmente, usam mais mecanismos de defesa, sentem mais desesperança, desamparo e depressão, necessitando de estratégias de apoio psicológico por parte da família, de amigos e da equipe assistencial.²⁷

A aparente simplicidade desse modelo acaba sendo de utilidade para o clínico cuidadoso, que deseja observar e pensar nas reações do paciente com o intuito de ajudá-lo a superar o estresse e aderir ao tratamento.

A imagem que o paciente faz da doença e de seu tratamento deve ser pesquisada em seus elementos concretos e subjetivos. Ideias errôneas ou distorcidas precisam ser desfeitas. A título de exemplo, um estudo prospectivo com 143 pacientes que haviam sofrido infarto do miocárdio demonstrou que o comparecimento às sessões de reabilitação associou-se à crença, durante a internação, de que a doença poderia ser curada ou controlada. O retorno mais rápido ao trabalho associou-se à percepção de que a doença duraria pouco e traria menos consequências negativas. Os que faziam pior ideia dela e de suas consequências tiveram pior desempenho nas medições de atividades de lazer e vida social. Esse resultado ilustra como as percepções sobre uma doença são determinantes na recuperação.²⁸

O profissional da saúde, junto com o paciente, deve procurar alternativas para tornar situações ameaçadoras mais seguras e auxiliar no reconhecimento e na expressão dos sentimentos vivenciados, compreendendo-os e oferecendo apoio psicológico. A provisão de informações, na medida necessitada e compreendida pelo paciente, é fundamental. Devem ser explicadas a natureza e a razão dos diversos procedimentos, e ideias errôneas devem ser corrigidas.²⁴

É crucial o *apoio social* recebido pelo paciente, mais em termos da qualidade do que da quantidade. Apoio social é um construto teórico com muitos componentes, e deve ser feita a distinção entre o apoio de fato disponível e a percepção que a pessoa faz em relação à adequação desse apoio. De qualquer forma, a associação com redução da mortalidade sugere que uma rede

de apoio social adequada pode, de fato, repercutir organicamente na redução do estresse e, em consequência, dos agravos à saúde.²⁶

LIDANDO COM A FAMÍLIA

Os familiares poderão estar angustiados com o adoecimento e a internação do paciente. Precisam ser tranquilizados, tanto pela quantidade adequada de informações quanto pela disponibilidade afetiva do profissional.

Exemplifiquemos por meio de uma situação clínica: “Você tem que reagir, tem que se esforçar para melhorar!”. Comentários como esse, às vezes, são feitos com o intuito de animar o doente. No entanto, eles têm o efeito contrário: acabam aumentando a culpa de quem já se encontra suficientemente desanimado e sem energia. Imaginemos um paciente vivenciando a doença como catástrofe ou o caso de uma pessoa que esteja deprimida: como ela se sentirá ao ouvir que a melhora só depende dela?

Fazer uma convocação para a melhora é, portanto, um erro. O adoecimento pode minar a vontade e a iniciativa de pessoas que, antes, eram batalhadoras e cheias de vida. Quem está deprimido, por exemplo, sabe o que deveria fazer, mas simplesmente não consegue iniciar uma ação. Sente um desânimo paralisante. Mesmo a realização de tarefas simples e rotineiras passa a ser muito difícil.

Quando fazemos essas considerações para quem cuida de um paciente deprimido, comumente ouvimos de volta: “Então a gente não tem de fazer nada? Se ele quiser ficar o dia todo deitado no quarto, sem se levantar, sem comer e tomar banho, a gente deixa?”. É hora de respirar fundo e continuar o diálogo, dedicando alguns minutos à psicoeducação de quem retrucou tão veementemente. Algumas orientações constantes do Quadro 2.6 podem ajudar familiares de pacientes deprimidos.

QUADRO 2.6

Orientações a familiares quanto ao que fazer e o que não fazer ao cuidar de pacientes deprimidos

O QUE NÃO FAZER?

- Fazer cobranças por melhora.
- Infantilizar a pessoa, tratando-a como se ela fosse criança.
- Desistir de ajudar.

O QUE FAZER?

- Compreender e apoiar tanto quanto possível; permanecer ao lado (tempo de qualidade, poderíamos dizer), fazendo o que for possível – coisas simples, como uma curta conversa ou um silêncio companheiro, um chá ou um suco, um programa leve na TV. Tudo isso para demonstrar compreensão e apoio.
- Gotas de otimismo. Quem está deprimido deve ser incentivado, sim, com delicadeza, a fazer pequenas coisas. Ao mesmo tempo, temos de respeitar sua necessidade de ficar mais quieto. Como o desânimo costuma ser pior de manhã, quem sabe não seria melhor tentar algo no fim da tarde? Um banho, um lanche leve, uma pequena caminhada, “desbravando” o corredor da enfermaria, etc. Quem está deprimido não consegue iniciar uma corrida, mas pode dar alguns passos, com ajuda e incentivo discretos. Em vez de cobranças, compreensão e gotas de otimismo!
- Mudar a lente. A depressão tira as cores e a alegria da vida, afeta a autoimagem, a autoestima, o interesse e a esperança. São comuns as ideias de incapacidade, de culpa, de ruína financeira, de doenças e de morte. O que fazer diante disso? Após ouvir com atenção e respeito, ajude a pessoa a ponderar, lembrando-lhe de que está tendo sentimentos e tirando conclusões influenciadas pela depressão.

Procure contrastar, com delicadeza, qualidades e realizações pessoais de outrora com as ideias e os sentimentos negativos atuais. Mas lembre-se: ajudar a ponderar não significa convencer por insistência, nem vencer uma disputa intelectual!

- Monitorar o tratamento. O tempo que um antidepressivo leva para fazer efeito, o agendamento de uma consulta de retorno, uma dúvida a ser sanada com o médico, ir à psicoterapia, lembrar de tomar os medicamentos, etc., são exemplos de obstáculos intransponíveis para quem, devido à depressão, está desanimado, sem energia e sem iniciativa. Um familiar pode ajudar o paciente deprimido ao cuidar de alguns aspectos práticos do tratamento.
- Prevenção do suicídio. Às vezes, a depressão se agarra ao desespero. A ideia de morrer, inicialmente rejeitada, passa a ser vista como a única saída para um tormento insuportável e sem fim. Algumas frases e reações podem sinalizar o risco de suicídio. O risco eleva-se quando a depressão coexiste com outras condições, como ansiedade, insônia e abuso de álcool, e quando, também, há meios letais facilmente acessíveis. Diante de qualquer dúvida, o médico deve ser contatado. É melhor dividir suas preocupações e não carregar sozinho o peso da responsabilidade pela vida de alguém.

Fonte: Botega.²⁹

ADESÃO AO TRATAMENTO

A maneira como cada indivíduo vivencia e enfrenta a doença é algo pessoal e função da personalidade, da capacidade de tolerar frustrações, das vantagens e desvantagens advindas da posição de doente, assim como de sua relação com as pessoas e seu projeto de vida.

Alguns pacientes lidam melhor com a enfermidade. Eles procuram se informar sobre a doença, seu tratamento e prognóstico. Geralmente são motivados para o tratamento, seguem recomendações médicas e promovem uma série de mudanças em suas vidas a fim de se adaptar, incluindo novas ocupações, participação em grupos de autoajuda, etc.

Outros têm dificuldades para seguir o tratamento recomendado. Em relação a isso, devemos conceber a adesão ao tratamento como um processo, com três componentes principais: a noção de que doença tem o paciente, a ideia de cura ou de melhora que se forma em sua mente e o lugar do médico no imaginário do doente. Cada um desses componentes contribui para a formação de uma opinião e uma tomada de decisões relacionadas à doença, sempre considerando a ideia de parar ou continuar o tratamento.³⁰

Vários fatores, resumidos no Quadro 2.7, associam-se ao descumprimento das recomendações médicas, incluídos os fatores relacionados ao comportamento do médico. Algumas sugestões práticas capazes de incrementar a adesão do paciente ao tratamento encontram-se no Quadro 2.8.

QUADRO 2.7

Fatores relacionados à falta de adesão ao tratamento

Paciente

- Tem concepções errôneas sobre a enfermidade ou tratamento.
- Compreende mal as instruções.
- Tem limitação na capacidade de acatar e de seguir orientações.
- Julga-se incapaz de seguir o tratamento.
- Duvida da utilidade do tratamento.
- Acredita que os benefícios não valem os esforços.
- É impaciente com a velocidade dos progressos.
- Tem outras preocupações como prioridade.

Tratamento

- Esquemas complexos
- Alto custo financeiro
- Efeitos indesejáveis
- Resultados em longo prazo
- Muita exigência em relação ao paciente
- Prejuízo na qualidade de vida

Doença

- Assintomática ou não incomoda muito.
- Sintomas dificultam o cuidar-se (p. ex., psicoses).

Instituição

- Travada por problemas de gestão

- Acesso difícil ao serviço
- Distante da residência do paciente
- Longo tempo de espera
- Atendimento de curta duração

Profissional

- Distante, pouco cordial, desinteressado, inacessível, impessoal, formal, etc.
- Parece sempre ocupado, com pressa, atende com várias interrupções.
- Usa jargões, não considera as dúvidas e preocupações do paciente.
- Não informa ou o faz de maneira imprecisa.
- Pergunta sobre coisas que o paciente não contaria sequer a amigos.
- Não oferece uma atenção contínua e personalizada, com retornos programados.

Fonte: Com base em Meichenbaum e Turk.³¹

QUADRO 2.8

Sugestões para aumentar a adesão ao tratamento

- Simplificar o esquema de tratamento, dividi-lo em passos.
- Ser pragmático: o que, como, quando, durante quanto tempo.
- Ser seletivo: pequena quantidade de informações a cada consulta.
- Dar informações claras e sem jargão médico, com instruções escritas.
- Orientações reforçadas na pós-consulta com a enfermagem.
- Empregar ilustrações, esquemas, analogias, etc., recursos mnemônicos, como deixar a medicação ao lado de objeto utilizado rotineiramente (escova de dentes, xícara de cafezinho).
- Verificar a compreensão (solicitar ao paciente para repetir o que entendeu).

Fonte: Com base em Meichenbaum e Turk.³¹

Em condições de doença crônica, o relacionamento entre médico e paciente será um exercício de paciência e de perseverança. Um acabará conhecendo e aprendendo a respeito do outro. Tratando-se de algumas afecções, sobretudo de distúrbios funcionais e de pacientes com certas características de personalidade, a relação médico-paciente será abalada em diversos momentos do tratamento. O paciente poderá se tornar exigente, hostil, pouco cooperativo, não aceitando as limitações impostas pela doença e seu tratamento.

Para o médico e para a equipe de saúde, pacientes crônicos podem despertar sentimentos de impotência, desesperança e desvalorização. Alguns já terão passado por diversos profissionais, incluindo os de maior prestígio, e a sensação que transmitem é a de que seremos o próximo a figurar em uma lista de “fracassos” que eles carregam e expõem.

Nesses casos, é fundamental avaliar cuidadosamente as modalidades relacionais estabelecidas entre o paciente e os médicos consultados anteriormente, bem como identificar sua opinião sobre medicamentos e regimes de tratamento, como se sente tendo de se tratar e qual a dimensão que o adoecimento tomou em sua vida. É preciso tentar compreender e contextualizar, segundo a história de vida do paciente, seu comportamento e os sentimentos que ele desperta em seu interlocutor.

A necessidade de psicoterapia deve ser trabalhada, de forma que o paciente se sinta estimulado a empreender algo que poderá ajudá-lo. Se a indicação for descontextualizada e extemporânea, o paciente poderá se sentir humilhado ou rejeitado por seu médico. Em continuidade ao assunto deste capítulo, o Capítulo 4 aborda uma situação clínica que afeta emocionalmente todo profissional da saúde: como lidar com um paciente problemático em decorrência de sua “personalidade difícil”.

REFERÊNCIAS

1. Leminski P. La vie em close. São Paulo: Brasiliense; 1995.
2. Freud S. Sobre o narcisismo: uma introdução (1914). Rio de Janeiro: Imago; 1974. v. 14.
3. Gala C, Bressi C. Psichiatria di consultazione. Milano: Utet; 1997.
4. Strain JJ. Psychological interventions in medical practice. New York: Appleton; 1978.
5. Langer M, Luchina IL. El médico frente al cáncer. In: Schavelzon J, editor. Cáncer: enfoque psicológico. Buenos Aires: Galerna; 1978. p. 129-85.
6. Tahka V. O relacionamento médico-paciente. Porto Alegre: Artes Médicas; 1988.
7. Laplanche J, Pontalis JB. Vocabulário de psicanálise. São Paulo: Martins Fontes; 1985.
8. Heimann P. On counter-transference. Int J Psychoanal. 1950;31:81-4.
9. Bleger J. Temas de psicologia: entrevista e grupos. São Paulo: Martins Fontes; 1980.
10. Botega NJ, Bio MR, Zomignani MA, Garcia Jr C, Pereira WAB. Transtornos do humor em enfermaria de clínica médica e validação de escala de medida (HAD) de ansiedade e depressão. Rev Saúde Pública. 1995;29(5):355-63.
11. Egede LE. Major depression in individuals with chronic medical disorders: prevalence, correlates and association with health resource utilization, lost productivity and functional disability. Gen Hosp Psychiatry. 2007;29(5):409-16.
12. Gaspar KV, Santos A, Azevedo RCS, Mauro MLF, Botega NJ. Depression in general hospital inpatients: challenges for consultation-liaison psychiatry. Rev Bras Psiquiatr. 2011;33(3):305-7.
13. Freud A. O ego e os mecanismos de defesa. São Paulo: Civilização Brasileira; 1977.
14. Klein M. Os progressos da psicanálise. Rio de Janeiro: Zahar; 1952.
15. Hackett TP, Cassem NH. Massachusetts general hospital: handbook of general hospital psychiatry. Chicago: Year Book Medical; 1987.
16. Spitz L. As reações psicológicas à doença e ao adoecer. Cadernos IPUB (Saúde Mental no Hospital Geral). 1997;6:85-97.
17. Fellini F. O misticismo do sofrimento ainda me irrita [entrevista]. Folha de São Paulo, 3 nov. 1993.
18. Ursano RJ, Epstein RS, Lazar SG. Behavioral response to illness. In: Wise MG, Rundell JR, editors. Textbook of consultation-liaison psychiatry. 2nd ed. Washington: American Psychiatric Publishing; 2002. p. 107-25.
19. Dalgalarondo P. Psicopatologia e semiologia dos transtornos mentais. 2. ed. Porto Alegre: Artmed; 2008.
20. Widiger TA. A dimensional model of personality disorder. Curr Opin Psychiatry. 2005;18(1):41-3.
21. Cloninger CR. A systematic method for clinical description and classification of personality variants: a proposal. Arch Gen Psychiatry. 1987;44(6):573-88.
22. McCrae RR, Costa PT. Personality in adulthood. New York: Guilford; 1990.

23. Rosenman RH. Type a behavior pattern: a personal overview. J Soc Behav Personal. 1990;5:1-24.
24. Weinmann J. An outline of psychology as applied to medicine. Bristol: John Wright; 1987.
25. Capra F. O ponto de mutação. São Paulo: Cultrix; 1982.
26. Henderson AS. An introduction to social psychiatry. Oxford: Oxford Medical; 1990.
27. Lazarus RS. Patterns of adjustment. New York: McGraw-Hill; 1976.
28. Petrie KJ, Weinman J, Sharpe N, Buckley J. Role of patients' views of their illness in predicting return to work and functioning after myocardial infarction: longitudinal study. BMJ. 1996;312:1191.
29. Botega NJ. Crise suicida: avaliação e manejo. Porto Alegre: Artmed; 2015.
30. Santos JQ. Adesão a tratamentos médicos. Psiquiatr Prát Méd. 2000;33(1):14-6.
31. Meichenbaum D, Turk DC. The cognitive-behavioral management of anxiety, anger and pain. In: Davidson PO, editor. The behavioral management of anxiety, anger and pain. New York: Bruner-Mazel; 1976. p. 1-34.



O médico e o cuidar

Neury José Botega

O encontro entre médico e paciente não é regido por elementos objetivos e racionais apenas. Ao entrar em contato com um doente, o médico recebe uma pessoa que traz à consulta sua visão de mundo e também suas dúvidas, aflições e expectativas conscientes e inconscientes. Em grau maior ou menor, mesmo o indivíduo mais equilibrado e forte, ao ficar doente, deposita no médico temores e esperanças, matizados por necessidades psicológicas primitivas. Neste capítulo, focalizamos como a pessoa do médico responde a essa demanda de seus pacientes, bem como a influência do contexto institucional nessa relação.

O CONHECIMENTO¹

Sócrates: E nunca ouviste falar, meu gracejador, que eu sou filho de uma parteira famosa e imponente, Fanerete?

Teeteto: Sim, já ouvi.

Sócrates: Então, já te contaram que eu exerço essa mesma arte?

Teeteto: Isso, nunca.

Sócrates: Pois fica sabendo que é verdade; porém, não me traias; ninguém sabe que eu conheço semelhante arte, e, por não o saberem, em suas referências à minha pessoa, não aludem a esse ponto; dizem apenas que eu sou o homem mais esquisito do mundo e que lanço confusão no espírito dos outros. A esse respeito, já ouviste dizerem alguma coisa?

Teeteto: Ouvi.

Sócrates: Queres que te aponte a razão disso?

Teeteto: Por que não?

Sócrates: A minha arte obstétrica tem atribuições iguais às das parteiras, com a diferença de eu não partejar mulheres, porém homens, e de acompanhar as almas, não os corpos, em seu trabalho de parto. Porém, a grande superioridade da minha arte consiste na faculdade de conhecer de pronto se o que a alma dos jovens está na iminência de conceber é alguma quimera e falsidade ou fruto legítimo e verdadeiro. Nesse particular, sou igualzinho às parteiras: estéril em matéria de sabedoria, tendo grande fundo de verdade a censura que muitos me assacam, de só interrogar os outros, sem nunca apresentar opinião pessoal sobre nenhum assunto, por carecer, justamente, de sabedoria. E a razão é a seguinte: a divindade me incita a partejar os outros, porém me impede de conceber. Por isso mesmo não sou sábio, não havendo um só pensamento que eu possa apresentar como tendo sido invenção de minha alma e por ela dado à luz. Porém, os que tratam comigo, suposto que alguns, no começo, pareçam de todo ignorantes, com a continuação de nossa convivência, quantos a divindade favorece progridem admiravelmente, tanto no seu próprio julgamento, como no de estranhos. O que é fora de dúvida é que nunca aprenderam nada comigo; eles mesmos é que descobrem as coisas belas que põem no mundo, servindo, nisso tudo, eu e a divindade como parteira. [...] Nesse ponto, os que convivem comigo se parecem com as parturientes: sofrem dores lancinantes e andam dia e noite desorientados, em um trabalho muito mais penoso do que o delas. Essas dores é que minha arte sabe despertar ou acalmar. É o que se dá com todos.

[...]

Sócrates: Volta, pois, para o começo, Teeteto, e procura explicar o que é conhecimento. Não me diga que não podes; querendo Deus e dando-te coragem, poderás.

Teeteto: Realmente, Sócrates, exortando-me como o fazes, fora vergonhoso não esforçar-me para dizer com franqueza o que penso. Parece-me, pois, que quem sabe alguma coisa sente o que sabe. Assim, o que se me afigura neste momento é que conhecimento não é mais do que sensação.

Sócrates: Bela e corajosa resposta, menino. É assim que devemos externar o pensamento. Porém, examinemos juntos se se trata, realmente, de um feto viável ou de simples aparência. Conhecimento, disseste, é sensação?

Teeteto: Sim.

Sócrates: Talvez tua definição de conhecimento tenha algum valor; é a definição de Protágoras, por outras palavras, ele dizia a mesma coisa. Afirmava que o homem é a medida de todas as coisas, da existência das que existem e da não existência das que não existem. Decerto já leste isso?

Teeteto: Sim, mais de uma vez.

Sócrates: Não quererá ele, então, dizer que as coisas são para mim conforme me aparecem, como serão para ti segundo te parecem? Pois tu e eu somos homens.

Teeteto: É isso, precisamente, o que ele diz.

Sócrates: Ora, é de presumir que um sábio não fale aereamente. Acompanhem-lo, pois. Por vezes não acontece, sob ação do mesmo vento, um de nós sentir frio e o outro não? Um ao de leve, e o outro intensamente?

Teeteto: Exato.

Sócrates: Nesse caso, como diremos que seja o vento em si mesmo: frio ou não frio? Ou teremos de admitir com Protágoras que ele é frio para o que sentiu arrepios e não o é para o outro?

Teeteto: Parece que sim.

Sócrates: Não é dessa maneira que ele parece a um e a outro?

Teeteto: É.

Sócrates: Ora, esse parecer não é o mesmo que ser parecido?

Teeteto: Perfeitamente.

Sócrates: Logo, aparência e sensação se equivalem com relação ao calor e às coisas do mesmo gênero; tal como cada um as sente, é como elas talvez sejam para essa pessoa.

Teeteto: Talvez.

Sócrates: A sensação é sempre sensação do que existe, não podendo, pois, ser ilusória, visto ser conhecimento.

Teeteto: Parece que sim.

A ciência clássica fomentou um modelo de pensamento que toma como objeto de conhecimento o que possa ser objetivo, tão delimitável quanto possível, mensurável e explicável. O singular deveria ser deixado entre parênteses ou descartado. Os acontecimentos seriam explicados por meio de “verdades” com força e natureza causais.

A teoria da relatividade e a mecânica quântica questionaram esse dogma. Destacaram, por um lado, a importância do observador e de seu esquema de referência, e, por outro, a inevitável existência do erro na observação dos eventos. Os parâmetros de observação da pessoa que observa, bem como seus pressupostos, passaram, então, a ser considerados fundamentais.

Nas premissas da ciência clássica, faltava o sentido do encontro entre quem observa e aquilo que se observa como matriz do conhecimento. Aquela não era capaz de captar os aspectos mais complexos dos sistemas vivos e da relação entre eles estabelecida.

Sabemos hoje que as informações que obtemos ao avaliar um paciente nascem da interação entre a teoria que abraçamos e os fenômenos sob observação. São resultantes da visão de mundo de quem observa, com suas teorias e idiossincrasias, sendo os “fatos” descritos pelo sujeito.

Apenas podemos conhecer por meio de nossa construção de mundo. A objetividade é ilusória, uma vez que se estabelece sobre o pressuposto de uma separação entre observador e observado. Enquanto observamos, devemos nos deslocar de uma realidade de *sistema observado*, baseada na objetividade, para uma realidade de *sistema observante*, auscultando-os.

Se é verdade que cada observador vê coisas diversas, também o é o fato de haver regularidades que modificam e tornam semelhantes certas reações humanas, bem como processos terapêuticos, regularidades que são evidenciadas em redundâncias e em similaridades. Dessa forma, podemos construir nossos modelos de entendimento do comportamento humano, incluindo suas crenças, seus afetos e suas reações.

O prólogo deste capítulo mostra Sócrates utilizando o diálogo como um poderoso instrumento de conhecimento. Essa interação sempre deixa espaço para descobertas e conclusões diversas daquelas anteriormente alcançadas. Sócrates acreditava não possuir qualquer saber já construído para dar ao discípulo, que era ajudado a esclarecer o próprio conhecimento íntimo. Nesse diálogo dialético (maiêutica), procurava-se compreender, estabelecer nexos.

O encontro terapêutico não deixa de ser um diálogo em que duas pessoas procuram trocar ideias e estabelecer nexos. Tal encontro movimenta-se nessa conjunção de realidades individuais – algumas inconscientes – condicionantes da relação interpessoal.²

Interação e negociação

Fala-se muito em relação médico-paciente; entretanto, seria preferível falarmos em *interação*. A resultante da interação não está estritamente relacionada, em termos objetivos e racionais, aos papéis de médico e de paciente ou à relação formal dessa díade. As relações interpessoais não diferem somente naquilo que os participantes fazem em conjunto (conteúdo da relação), mas também em como o fazem (qualidade da relação). Esta última depende dos afetos evocados nas pessoas envolvidas e se manifesta, sobretudo, por meio dos aspectos não verbais do comportamento.²

Mas de onde derivariam tais afetos evocados pelo adoecimento, agora trazidos à consulta médica? Vimos, no Capítulo 2, como o médico é depositário de fantasias repletas de elementos mágicos que configuram a *transferência*. O paciente espera reencontrar a capacidade parental de aplacar a angústia e de transformar fantasias aterrorizantes em pensamentos aceitáveis. O exagero nessa expectativa transforma o médico em um ente poderoso, capaz de controlar e domar os perigos.³⁻⁵ A *contratransferência* compreende os processos inconscientes do médico, que aparecem na superfície sob forma de sentimentos e ações dirigidas ao paciente.^{6,7}

A interação que se estabelece entre médico e paciente pode ser concebida também como uma *negociação*, ou como a resultante de um compromisso entre as “ofertas” e as exigências do paciente, de um lado, e as respostas do profissional, do outro. Quando adoecemos, “oferecemos” ao médico nossas queixas e problemas. Essas ofertas e demandas emocionais são organizadas pelo médico em uma forma “aceitável” de doença.⁸

O encontro entre médico e paciente envolve um *jogo de identificações* e a busca de encaixes, ou afinidades, entre duas pessoas. A linguagem funciona como intermediária nessa relação e

necessita ser decodificada (ver Cap. 17 para o exemplo dos sintomas físicos sem explicação médica). Quando essa decodificação não ocorre, ou quando o resultado da consulta foge das expectativas do médico ou do paciente e de seus familiares, desencadeia-se uma crise de confiança. Essa crise, vivenciada por todos os participantes da relação, pode interferir profundamente no curso do tratamento.

Entre médico e paciente há, também, uma *relação de poder*, ou seja, assimétrica. De um lado, uma pessoa com uma demanda, sofrendo, em situação de vulnerabilidade. De outro, alguém que dispõe de um saber. O profissional poderá desempenhar estritamente um papel técnico, de prestação de serviço, ou se abrir e oferecer ouvidos atentos e acolhimento.⁹

Tal relação de poder, analisada em termos essencialmente humanos, parece muito frágil quando se leem as seguintes interpolações, que, no avesso da poesia, revelam a vulnerabilidade de quem cuida:

Você está mal, mas eu estou bem.
Você pode morrer, mas eu não.
Você está doente, mas eu estou são.
Você não sabe o que fazer, mas eu sei.
Você tem medo, mas eu não tenho sentimentos.

Mesmo fugindo do escopo deste capítulo o aprofundamento em aspectos antropológicos e sociológicos do adoecimento, é preciso reconhecer, em poucos parágrafos, que o curso da relação empreendida entre médico e paciente é condicionado pelas influências do sistema de saúde, do convênio médico, das concepções compartilhadas pela família e também por uma série de normas sociais e institucionais.

O tipo de enfermidade que o indivíduo tem, ou acredita ter, o que os outros pensam de sua doença e as expectativas acerca do paciente não dependem clara e simplesmente do diagnóstico médico, e sim de um juízo social em um contexto cultural. Também há *negociações sociais* na relação que se estabelece entre médico e paciente.¹⁰ Atualmente, também há, entre esses dois protagonistas, interferência da gestão pública e dos convênios médicos particulares.

Além disso, é possível encontrar, no homem de hoje, reflexos de seus medos ontológicos, bem como das raízes históricas da medicina, que são resultantes do período xamanístico, da medicina oriental e de práticas hipocráticas. Agentes causadores de doenças são concebidos como castigo ou como demônios que nos atacam. Recorre-se, então, a práticas exorcistas quando não se tem acesso a mecanismos fisiopatológicos ou de cura, sendo a doença concebida como uma entidade com vida própria (personificação da doença, coisificação do homem), em um sistema de crenças em consonância com a concepção cultural da doença.

Em nossos dias, observa-se uma retomada da noção hipocrática de que a saúde requer um estado de harmonia entre fatores ambientais, estilo de vida e outros componentes da natureza humana. O médico pode acompanhar o processo de restabelecimento de uma doença, como os terapeutas da antiga Grécia, mas a principal responsabilidade cabe ao indivíduo, que tem o dever de se manter saudável.

O MÉDICO

A palavra “médico” vem do latim, *medeor*, que significa pensar, entender, julgar, ser inspirado, estar entusiasmado. A palavra “terapeuta” vem do grego, *therapeuin*, que significa o servidor que acompanha o doente, auxiliando o poder curativo da natureza.

Em relação à vocação para a medicina,¹⁰ em geral, fala-se de um talento inato, de um “Eros terapêutico”, que é algo mais do que um amor humanitário que o médico possa sentir por seu paciente, é um movimento autêntico para o indivíduo que está diante dele, e que não é um doente, mas um ser humano.

As motivações para a escolha da medicina como profissão são de cunho sociológico, econômico e psicológico. Influem o ambiente familiar e o *status* que a profissão goza na sociedade, trazendo honra, prestígio e gratificação a desejos altruístas de curar os doentes e de atendê-los em suas necessidades. A isso somam-se uma sociedade que necessita de médicos, os ganhos financeiros que possam ser aferidos com a profissão e a disponibilidade econômica para cursar uma faculdade.

De onde você tira sua capacidade de cuidar?

As reflexões feitas a seguir derivam das discussões de um grupo de estudos que realizamos na Universidade Estadual de Campinas. Estávamos interessados em nos aprofundar sobre o que nos movia e poderia nos sustentar psicologicamente, quando atendemos pessoas em crise.

Decidiu-se que cada um dos membros de nosso grupo de estudo faria a pergunta que abre esta seção a duas pessoas admiradas por sua capacidade de cuidar. A seguir, destacam-se trechos significativos de alguns depoimentos. São reveladores e levam à reflexão de como escolhemos e exercemos a profissão, integrando-a ao dia a dia de nossas vidas e ao sentimento que nutrimos a respeito de nós mesmos.¹¹

Certas experiências que tivemos ao longo da infância e da adolescência provavelmente nos conduziram para profissões da área da saúde – acontecimentos que geraram sensação de desamparo, vivências que produziram uma aprendizagem sobre o cuidar, como o tornar-se mãe, ou ter sido objeto de cuidado.

Médica, 25 anos

Acho que existem alguns “pilares” ou pontos de partida:

- **Sentir-se capaz.** Acredito ser fundamental a pessoa que cuida de alguém (ou de algo) sentir-se capaz de fazê-lo... Por exemplo, para eu cuidar de um paciente, devo, pelo menos, achar que, de alguma maneira, posso ajudá-lo. Mas veja que são duas coisas diferentes: sentir-se capaz de algo e ser gabaritado para algo.
- **Ter o mínimo de amor pelo outro, compaixão, empatia.** É isso que vai ser a força motriz em direção ao cuidado de fato: ser tocado pela dor do outro.
- **Ter satisfação pessoal ao ajudar alguém.** Essa é a parte um pouco egoísta do processo. Querendo ou não, quando cuidamos de alguém e nos sentimos felizes por tê-lo feito, parte dessa felicidade se dá porque a outra pessoa ficou feliz

(e gratificada). A outra parte da felicidade é porque nós fizemos algo “bonito”. Alegro-me porque me sinto útil e, assim, mereço existir; faço parte de algo maior... Acho que isso é a tal transcendência.

■ **Acreditar no potencial de mudança do outro.** Acho que qualquer cuidador ganha força extra quando vê seu objeto de cuidado se esforçando para melhorar. Aqui cito um exemplo do posto de saúde: tem um velhinho, o seu João, com sequela de um “derrame”, dois infartos do miocárdio prévios, acamado, usando fralda e sonda vesical (pois tem também hiperplasia prostática benigna) e, para completar, deprimido. Quem cuida 24 horas dele é a esposa, dona Ana, de 80 anos, sofrendo atualmente de hipertensão arterial refratária, que tem que cuidar da casa, da lavoura e do gado também (sozinha). Toda vez que vamos fazer visita domiciliar é a mesma coisa: dona Ana reclama que ela faz tudo para ele; faz comida, troca fralda, faz companhia... Mas que ele passa todo o tempo gemendo e falando que quer se matar, que ela tem que ajudar ele a se matar, que ele vai matá-la e depois se matar... Ela nunca reclamou das coisas que tem que fazer por ele durante o dia (e à noite, já que ele não dorme e, consequentemente, nem ela). Mas toda vez reclama que o que a deixa frustrada é ele não querer continuar, é ele querer desistir, apesar de tudo o que ela faz por ele... [Sim, já comecei tratamento antidepressivo para ele, caso fosse a próxima pergunta...].

Acho que, quando a pessoa também demonstra que quer mudar (independentemente de quanto tempo levará ou se efetivamente essa mudança vai ocorrer), é muito mais fácil para o cuidador.

A identificação com cuidadores, principalmente figuras maternas e paternas, reais ou idealizadas, faz acreditar na relação de ajuda e na própria capacidade de exercê-la. Essa identificação produz a sensação de que estamos fazendo algo bom e valorizado. Também gera confiança, paciência e determinação, que são, afinal, fundamentais para a capacidade de cuidar.

Em uma visão psicanalítica, as brincadeiras infantis e seu corolário, com as fantasias inconscientes que expressam, são a matéria-prima da inclinação vocacional. No caso do médico, a fantasia primitiva estaria centrada na esperança e na necessidade de curar e recuperar seus objetos queridos.³

Freud,¹² em 1910, já havia reparado que o brincar de médico também satisfazia impulsos infantis de curiosidade sexual. Posteriormente, sem perder sua intensidade, essa pulsão deslocaria seu alvo para outros objetos, não sexuais: “O instinto sexual presta-se bem a isso, já que é dotado de uma capacidade de sublimação, isto é, tem a capacidade de substituir seu objeto imediato por outros, desprovidos de caráter sexual e que possam ser altamente valorizados”.¹²

O brincar de médico também funciona como um jogo de identificações, no qual a criança assume ora o lugar de uma mãe confortadora, que alivia a dor, ora o papel do pai. Nesse caso, a brincadeira funciona como uma tentativa de superar ativamente experiências prévias de temor e desamparo. A identificação com os genitores, assim obtida, reconforta e fortalece a autoestima.

No dia a dia, o médico atende pais, mães, crianças, pessoas que lembram algum aspecto de si mesmo – algo que ele também é, foi ou será – ou de alguém muito querido. Certa vez, um médico residente comentou que havia passado duas horas interrogando “uma mãe desnaturada” que havia entregue sua filha para adoção: “Tenho algo semelhante em minha vida. Acabei indo morar com meus avós quando era criança. Achava que minha mãe tinha me abandonado. No fundo acho que ela devia ter insistido mais comigo, devia ter ficado comigo”.¹³

O “pensar que eu poderia ter nascido ele”, também ligado a esse mecanismo psicológico de identificação, é outra ideia que, de tempo em tempo, assalta o profissional da saúde. É o que se depreende do depoimento de um neurologista:¹³

Quando a gente pega um paciente jovem com quadro de mielopatia, por exemplo... O paciente começa a desenvolver uma paraplegia, tetra... e até chegar a isso lança-se mão de muitas coisas e..., ou você não consegue por problemas financeiros, estrutura do hospital..., ou consegue tudo isso e não consegue o diagnóstico, por estar além do seu conhecimento... É uma coisa angustiante, e a gente se identifica, acaba vivendo no lugar dele... Pensar que eu poderia ter nascido ele.

Esse é um aspecto específico das profissões da área da saúde: a necessidade de reparação tem de ser feita tão concretamente, sobre seres humanos tão semelhantes aos cuidadores, que deixa vulnerável quem a exerce. Em uma quantidade considerável de casos, o paciente põe o médico em posição, em disposição, inclusive o intima a responder a uma demanda de reparação.

O médico, ao ter atribuído a si esse desejo, pode até se sentir valorizado. Assim, os intensos desejos de dependência do paciente encontram guarida em um profissional igualmente movido por uma necessidade onipotente de fazer algo a qualquer custo pessoal. Passa a atuar, então, *em defesa do paciente*. A onipotência subjacente a essa demanda e a essa resposta impõe-se fortemente no determinismo da conduta terapêutica, ainda que possa, também, ser lida como seu reverso: o padecimento pela impotência.¹⁴

Discutiui-se muito sobre essa temática durante os encontros desse nosso grupo de estudo – a visão psicodinâmica sobre a *necessidade de reparação*, sobre algo *dentro* de nós, do qual cuidamos ao cuidar de nossos pacientes. Teríamos nós, os profissionais da saúde, maior capacidade para reagir diante de situações de desamparo, justamente por termos vivenciado, um dia, esse sentimento? Cuidar do outro tem algo a ver com cuidar de mim, do meu próprio desamparo?

Como reagem os médicos

Na formação médica, a maioria das conexões de sentido feitas a respeito das doenças é colocada fora do sujeito, na ciência, e não no sujeito com suas vivências e história de vida. Esse tipo de treinamento aumenta a dificuldade do profissional para lidar com o sofrimento que não possa ser diretamente relacionado a uma alteração anatômica ou a uma explicação fisiopatológica circunscrita ao corpo do paciente.

Alguns médicos se angustiam muito quando percebem que lidar com o sofrimento de um paciente está além de sua capacitação profissional. Outros se sentem incomodados com as demandas emocionais. Procuram, então, restringir sua atuação a aspectos técnicos, valendo-se de diversos mecanismos de defesa, sobretudo evitação, isolamento de emoções, intelectualização, sadismo e humor negro.¹⁵

O depoimento seguinte revela algo das vivências de um médico que entrevistamos em um estudo sobre aspectos psicológicos da prática médica:¹³

O que mais me afeta é a mulher que está grávida e rejeita a gravidez ou a criança. Lembro-me de plantões que fazia no início da carreira, em que tinha que realizar várias curetagens pós-aborto. Então fazia sem anestesia, como uma parte da punição a uma criminosa... E a gente assumia isso: “Fez aborto?! Agora sofre!”. A gente se influenciava pelo ambiente. Mas ao longo do tempo mudei minha atitude, porque ninguém aborta por prazer. Aborto é uma experiência terrível pra mulher. Atualmente sinto pena.

Para se colocar acima da enfermidade e imune à morte, alguns médicos constroem um *pseudo-self*, idealizado e mitológico, que, por meio de mecanismos de defesa, leva-os próximo do divino.¹⁶ Outros desenvolvem verdadeiras couraças protetoras, que lhes impedem de se sensibilizar e utilizar as próprias reações emocionais como instrumento semiológico.

A falha, ou a derrubada desses mecanismos de defesa por uma condição pessoal, uma situação clínica difícil, ou um insucesso terapêutico, faz o médico se defrontar com a impotência. E são muitas as impotências vivenciadas – diante da desgraça social, da morte, do paciente que não melhora logo, ou diante daquele “que se queixa sabe-se lá de quê”. Seguem, a esse respeito, outros relatos de médicos por nós entrevistados:¹³

O paciente que me faz mal é o que tem doença de Chagas, porque são pacientes que a gente tem pouco ou nada a fazer por eles. É o tipo de paciente que é um coitado na vida. É revoltante, pois, quando eu estava na faculdade e atendia esses pacientes com Chagas, eu pensava o seguinte: “Isso aqui um dia vai acabar...” E a gente tá, hoje, recebendo pacientes que tô vendo que foram infectados quando eu estava no curso médico.

Pra mim, é a angústia de ver logo melhorar o paciente, ter que quebrar a cabeça, ficar em cima dele, esperar ele melhorar... Você quer resolver logo e sabe que vai demorar... coma hepático, encefalopatia hepática... Fico muito angustiado com isso aí, não tenho paciência... [...] Eu, como residente, agora tô com uma angústia maior. Era mais feliz quando era interno.

A gente acaba conversando com a família, com os amigos, conta uns casos... Aquela história, né, que médico não para de falar de medicina nem quando tá passeando. Então, talvez, seja nessa hora que tem a válvula de escape, ficar falando, contar pros amigos os casos dos pacientes... Eu, por exemplo, conto mais em casa.

No extremo oposto da onipotência ou da couraça protetora, há o risco de uma identificação excessiva com os pacientes atendidos e de acabar sofrendo junto com eles. Às vezes, o profissional se identifica tanto com uma pessoa enferma que acaba se confundindo com ela, vai se entristecendo, se sentindo abatido, “carregando-a” para casa nos fins de semana, perdendo a sensação de que, afinal, tem direito à felicidade, independentemente da dor de quem esteja ele cuidando.

Para poder trabalhar de forma adequada, sem sobrecarga de tensão, onipotência ou culpa, deve-se adquirir maturidade e capacidade de aceitar as limitações impostas pela realidade. É preciso não confundir os enfermos com nossas crenças e nossos sentimentos e tolerar a frustração do fracasso, da incurabilidade e da morte.³

Armadilhas do narcisismo

Segundo Maltsberger e Buie,¹⁷ as três mais frequentes armadilhas do narcisismo são: saber tudo, amar todos e curar todos. A menos que essas propensões sejam elaboradas, o médico será tomado por sentimentos de desamparo e desalento e tentará resolver seu dilema por meio de ações mágicas ou destrutivas. Em seu texto, os autores referem-se a pacientes difíceis, que utilizam mecanismos primitivos de defesa e que mobilizam muito seus psicoterapeutas. Ainda assim, pensamos que as advertências e os conselhos sejam úteis a todo profissional da saúde. Vejamos algumas das armadilhas do narcisismo exemplificadas por esses autores:

De anjo a demônio. No início do tratamento, o terapeuta pode ser idealizado e visto como um ser de vastos poderes. Pode ouvir algo assim do paciente: “É por isso que gosto de vir aqui. Só você, e ninguém mais, consegue me compreender e me ajudar”. Sentindo-se vaidoso e onipotente, o terapeuta pode transformar os desejos do paciente em expectativas realistas que precisam ser por ele preenchidas. A partir daí, não poderá falhar. Sabemos, no entanto, que esse terapeuta idealizado – um anjo –, de uma hora para outra, poderá ser transformado, pelo paciente, em demônio.

O tratamento requer o reconhecimento e o manejo de expectativas mágicas. Elas são problemáticas e levam, inevitavelmente, ao desapontamento. Para se sentir satisfeito e confiante em sua tarefa profissional, o terapeuta deve se pautar no pleno exercício de suas habilidades, de acordo com o melhor conhecimento disponível, e não nas *curas* que consegue realizar.

Intuição mágica. Os pacientes gostam de pensar que seus terapeutas são capazes de *saber* o que eles estão pensando e sentindo sem que precisem falar sobre seus pensamentos e sentimentos. Isso pode encontrar eco em um profissional que acredita ter sido aquinhado por especial capacidade de intuir e de sentir o que se passa com outra pessoa.

A marca de um terapeuta experiente e habilidoso é que ele não se vale de suas intuições além de certo ponto. Seus pressentimentos estão sempre sendo examinados no contexto do material clínico. De fato, se perguntarmos a um clínico experiente como ele teve um palpite feliz, ele será capaz de dar uma boa resposta com base nas informações clínicas que obteve e considerou cuidadosamente.

Amor missionário. Ser um terapeuta cuidadoso é tão importante para o paciente quanto para a autoestima profissional. Especialmente no início da vida profissional, nos cobramos essa capacidade de cuidar amorosamente de todos os pacientes. No entanto, certos pacientes – notadamente os psicóticos e *borderline* – frequentemente acusam o terapeuta de estar sendo frio e indiferente. Baseiam-se em um simples gesto ou em uma frase retirada do contexto para comprovar suas suspeitas de um terapeuta egoísta e interesseiro.

Com a experiência, os terapeutas passam a relativizar suas expectativas iniciais de amar todos os seus pacientes. Na mesma proporção, cresce sua habilidade de enfrentar ataques a sua capacidade de cuidar e de manter sua autoestima, mesmo quando são ruidosamente acusados de desamor.

Irving Yalom,¹⁸ psiquiatra, psicoterapeuta e escritor famoso, lembra-nos algo mais a respeito das respostas que devemos dar às demandas que podem reforçar o narcisismo:

Mais de um dos meus pacientes evocaram a metáfora do Mágico de Oz para descrever sua preferência pela crença feliz de que o terapeuta conhece o caminho para casa – um caminho livre e seguro, sem dor. De forma alguma eles querem olhar por trás da cortina e ver um falso mágico perdido e confuso.

[...]

Talvez existam ocasiões em que precisamos oferecer *magia, mistério e autoridade* – ocasiões de grande crise ou em que nossa prioridade é tranquilizar o paciente para a terapia. Mas, se precisar flertar com o papel de mago, aconselho a manter o flerte breve e voltado para ajudar o paciente a fazer rapidamente a transição para um relacionamento terapêutico mais genuíno.¹⁸

O depoimento a seguir, motivado pela pergunta surgida em nosso grupo de estudo (*De onde você tira sua capacidade de cuidar?*), ilustra o que um jovem médico procura fazer a fim de preservar sua capacidade de cuidar.

Médico, 31 anos

Se houvesse um órgão chamado “paciência” no ser humano, eu diria que retiro a minha capacidade de cuidar do fundo da minha paciência. Acho que a famosa “compreensão do outro”, no meu caso, é o resultado do exercício de uma paciência capaz de esperar o momento em que o sujeito cuidado esteja pronto para tal. Sem isso, a meu ver, o cuidado torna-se invasivo, uma vez que não se trata de impor moral de uma boa conduta de vida, mas sim de sentir o momento em que o outro precisa de ajuda, estando disposto a ser ajudado. Nesse ponto, entra a disponibilidade.

Aqui é importante ressaltar que a disponibilidade de cuidar do outro nunca, no meu caso, é maior do que a disponibilidade de cuidar de mim (será que isso é um contrassenso?). Somente assim tenho forças para cuidar continuamente, se necessário, pois me preservo de exagerar e faço “pausas” nessa atividade, que, sem precaução alguma, é extenuante. É nessas pausas para cuidar de mim (ficar com minha esposa, estudar, ler história e sociologia, jogar e outras coisas das quais eu gosto) que encontro tempo para refletir sobre tudo, inclusive sobre meu cuidado. É assim, “tomando conta” da minha capacidade de cuidar, que mantenho as forças para continuar essa tarefa. Tento de me cuidar para poder desenvolver bem o meu trabalho.

O cuidar de mim para cuidar dos outros e o tomar conta de minha capacidade de cuidar são fundamentais para quem trabalha com crises humanas. É imprescindível tomar alguns cuidados em prol de nossa própria saúde mental. São coisas tão simples quanto essenciais: reservar tempo de qualidade para si e para a família, retomar antigos costumes que traziam alegria e paz (abandonados por falta de tempo), limitar o número de pacientes que provocam sobrecarga emocional, fazer pausas para reflexão, contar com psicoterapia pessoal e com supervisão clínica, organizar, com os colegas, um grupo de estudos e um encontro rotineiro, a fim de discutir situações clínicas mais difíceis ou angustiantes.

O CONTEXTO INSTITUCIONAL

Quando as instituições assistenciais são criadas, sua principal finalidade é atender às necessidades da população, oferecendo aos profissionais que nela trabalham os recursos para tanto.

No contexto institucional, as respostas a essas necessidades são, cada vez mais, reguladas por uma instância supraclínica, que estabelece uma estrutura fundamental, definindo espaço, tempo, procedimentos padronizados, rotinas de atendimento, ou seja, uma série de recursos materiais e humanos. É dessa forma que um conjunto de normas e de rotinas vai sendo criado, institucionalizando-se.

A velocidade com que as coisas acontecem, aliada ao nosso envolvimento com elas, muitas vezes impede essa visão da instituição como um todo e de como ela interfere na assistência, ao estabelecer um regime que privilegia a ação e restringe o tempo de reflexão e de elaboração.¹⁸

Ao mesmo tempo que regula esse território, o médico é apenas uma variável a mais na tarefa assistencial. Sua atuação depende de sua própria inserção na instituição, marcada por aspectos conflitantes: por um lado, é quem deve implementar normas para regular a assistência, e, por outro, está sujeito a obedecer às normas que controlam sua vida profissional.¹⁹⁻²¹

O caráter ambíguo da instituição, de um lado protegendo e gratificando e, de outro, impedindo o bom desempenho assistencial, presta-se à projeção de conflitos pessoais sobre os demais elementos do grupo ou sobre aspectos da própria instituição. No plano institucional, recria-se um padrão semelhante àquele observado nas primeiras relações interpessoais.²²

Às vezes, a representação que se tem da instituição é a de uma entidade que nos invade e suga, é distante, independente, superior e dominadora. A ideia aproxima-se, desse modo, da *imago* paterna: protetora e castradora; outras vezes, assemelha-se à *imago* materna: alimentadora e devoradora, que exige sacrifícios.²³

As formas e os conteúdos primitivos do *dar* e do *receber* repetem-se na situação institucional. Os objetos internos bons são mantidos com o sujeito, reforçados pela instituição. Os objetos internos maus, que poderiam causar danos, acabam depositados (projetados) na instituição, para a qual são canalizados sentimentos de frustração e de hostilidade. A instituição passa a ser, assim, responsabilizada por muitos conflitos que seus profissionais revivem em situações clínicas.

No entanto, a instituição também tem uma função reparadora: permite que as pessoas projetem nela suas partes danificadas e introjetem algo modificado, menos destruído. São aspectos que denotam o caráter primitivo e inconsciente das emoções que cercam a relação dos profissionais com a instituição na qual trabalham.^{22,24}

Outro conceito nascido da psicanálise e aplicado a grupos e instituições refere-se à *compulsão à repetição*, mecanismo pelo qual, na tentativa de elaboração de conflitos, leva as pessoas a agirem e reagirem sempre de modo semelhante. Consideramos válida, entretanto, a advertência de Grinberg e colaboradores²⁴ quanto à conotação metafísica do termo, que, ao que parece, reserva às instituições um caráter trágico e inexorável, unicamente baseado em fatores psíquicos.

Ainda assim, julgamos que a noção de compulsão à repetição pode ser um fator envolvido em muitas das resistências que as propostas de mudanças na instituição são capazes de levantar. Os membros da instituição, muitas vezes, opõem-se a mudanças, parecem evitar situações novas e desconhecidas, recorrendo a um sistema de normas já conhecido e seguro. Muitas dessas normas foram criadas para dar segurança (evitar problemas), garantindo, ao médico e à equipe assistencial, a distância dos conflitos pessoais no contato com os pacientes.

Não se trata de negar as diversas condições institucionais cujos determinantes têm origem política, econômica e cultural, que se interpenetram com a dimensão psicológica e interferem na assistência. No entanto, sob o ponto de vista da psicologia, um conjunto de normas institucionais tem caráter econômico de defesa.

No Capítulo 7, exemplifica-se, por meio de uma visão psicodinâmica das interconsultas, como o que se expôs até aqui pode ser aplicado à compreensão do processo de encaminhamento ao psiquiatra. Muito de nossas observações deriva de uma realidade de hospital-escola, mas acredita-se que os exemplos possam se adequar a vários contextos assistenciais.

Cada vez mais, os cuidados com a saúde são prestados por uma equipe multiprofissional dentro de um contexto institucional, que pode funcionar de maneira dissociada – cada um cuidando de uma parte do paciente. A responsabilidade final pelo que ocorre ou deixa de ocorrer fica diluída, empobrecendo o relacionamento entre profissional e paciente, afetando, assim, o tratamento. Balint chamou esse fenômeno de *cumplicidade no anonimato*, no qual ninguém se responsabiliza pelo que ocorreu ou deixou de acontecer.⁸

A instituição funciona como intermediário, regulando esse intercâmbio com normas explícitas e implícitas. Se esse caráter intermediário crescer, deixa de ser meio para ser fim. Cria-se, então, um paradoxo: a assistência torna-se entorpecida por processos grupais e institucionais, não atendendo às necessidades daqueles que buscam a instituição.

Com isso, não ficam sem atendimento somente as necessidades supostamente prioritárias da população, mas também as necessidades do grupo profissional que aí atua. Para complicar, as demandas dos pacientes e dos profissionais se dão dentro de uma instituição que gera suas próprias urgências, que, com frequência, são colocadas acima das outras. Esse entrechoque entre a função da instituição e os interesses dos grupos que nela circulam é o que se conhece como *paradoxo assistencial* das instituições que prestam assistência médica.²¹

O LUGAR DA PSICOLOGIA MÉDICA

Hipócrates escreveu a primeira página da história da psicologia médica, que permaneceu por muitos anos sem adição de uma linha. Ao terapeuta, cabia auxiliar o “poder curativo da natureza”, permanecendo ao lado do enfermo, assistindo-o e cuidando-o (*therapeuin*). Com o passar do tempo, no entanto, foi se tornando cada vez mais difícil ser um asclepiáde moderno.

Kretschmer, considerado o patriarca da psicologia médica, defendeu-a, em 1922, como disciplina especial e independente. Segundo ele, tal psicologia deveria “preencher a lacuna existente na formação médica, ligando a cultura puramente médica e naturalista ao domínio das ciências morais” e, também, “por meio de uma psicologia nascida da prática médica, atender necessidades práticas do exercício profissional”.²⁵

Foi, no entanto, Balint, na década de 1950, o grande inspirador da psicologia médica. Foi ele quem nos mostrou a maneira de aprender e ensinar nesse campo. Sua obra impressiona, acima de tudo, pelo fato de, praticamente, não haver qualquer ponto de importância na relação médico-paciente e na psicoterapia aplicada à medicina que ele não tenha abordado.⁸

Na época em que muitos médicos generalistas britânicos tinham de atender solicitações reiteradas de pacientes funcionais inscritos em suas listas, Balint passou a coordenar reuniões semanais de discussão a respeito dos problemas psicológicos da prática médica, em uma estratégia que ficou conhecida como *grupos Balint*.²⁶

É um prazer ler e reler Balint – dissecação fina da alma do médico escrita com estilo. Suas principais contribuições encontram-se em *O médico, seu paciente e a doença*, publicado em 1957,⁸ e em *Técnicas psicoterapêuticas em medicina*, de 1961. Com David Malan, desenvolveu as principais teses da psicoterapia focal. Inspirados por suas ideias, psicanalistas e médicos generalistas, professores e alunos têm-se aglutinado em diversas associações. A primeira delas surgiu em 1967, a Société Française des Groupes Balint. E, em 1970, ano em que Balint morreu, foi fundada, em Londres, a Balint Society.²⁷

Como ciência, a psicologia médica não pode ser considerada nova, nem autônoma, especial ou independente. É uma modalidade da psicologia aplicada à medicina e se nutre de diversas fontes. Pode ser concebida mais como atitude – um recurso para ampliar e aprofundar a capacidade de compreensão do médico.²⁸ A psicologia médica não é o estudo da relação médico-paciente, é o estudo do médico *em relação* com seu paciente, com a sociedade e, fundamentalmente, consigo mesmo.

No *Manual de psicologia médica*, que, por muitos anos, foi o mais frequentemente adotado nas escolas médicas do Brasil, Jeammet e colaboradores⁹ faziam de uma pergunta o título de um capítulo – por exemplo “A psicologia médica tem um lugar no contexto de uma medicina científica?”. Os autores reconheciam o conflito clássico entre uma medicina da doença e uma medicina mais global, centrada no ser humano doente. Acrescentavam que a situação médica é um modelo de interação concreta, no qual o homem deveria ser estudado em sua situação concreta. Opunham-se, portanto, à psicologia abstrata: “É preciso apreender o sujeito em sua vida dramática”.

Nos dias de hoje, o conhecimento científico, respaldado por um aparato tecnológico, pode estar permitindo uma evitação fóbica de alguns professores em relação ao contato com o aluno de medicina e, de modo geral, com os pacientes. Esse também é um dilema da psiquiatria contemporânea, que passou a ser fortemente calcada na neurociência, no diagnóstico operacional e nas terapias biológicas.

A psicologia médica transformou-se em nova arena de debates entre o objetivo e o subjetivo, o explicativo e o compreensivo.²⁹ Entretanto, os objetivos e métodos da psicologia médica não são delimitados com facilidade. Um levantamento que alcançou faculdades de medicina de nosso país confirmou a impressão de que o conteúdo programático, o método pedagógico e a carga horária adotados no ensino dessa disciplina são muito variáveis.³⁰ Ainda hoje, é possível que algumas instituições ensinem psicologia médica de forma exageradamente conceitual e abstrata, bem distante da realidade do médico.

A tarefa central e prática de uma disciplina de psicologia médica é propiciar ao estudante que está começando a atender um espaço para entrar em contato com seus sentimentos e suas reações diante dos seres humanos, diante de situações concretas. Um espaço que priorize a reflexão e a troca de experiências. A partir de diferentes estratégias, é também o médico (ou o estudante de medicina) que precisa ser apreendido em sua “vida dramática”. Trata-se de utilizar a vivência como instrumento de aprendizagem e de semiologia.

O ensino da psicologia médica vinculado ao da interconsulta psiquiátrica pode propiciar a estudantes, notadamente aos do internato, e a residentes de medicina a oportunidade de observar a importância dos fatores psicossociais envolvidos na doença, bem como a influência da relação médico-paciente no comportamento e na evolução deste. Assim, a interconsulta psiquiátrica pode assumir um papel fundamental no processo de educação, ao participar de situações concretas do exercício profissional e ao propor uma atitude reflexiva sobre a prática clínica.

REFERÊNCIAS

1. Platão. Diálogos. Belém: Universitária UFPA; 1988.
2. Andolfi M. A linguagem do encontro terapêutico. Porto Alegre: Artmed; 1996.
3. Langer M, Luchina IL. El médico frente al cáncer. In: Schavelzon J, editor. Cáncer: enfoque psicológico. Buenos Aires: Galerna; 1978. p. 129-85.
4. Tahka V. O relacionamento médico-paciente. São Paulo: Artes Médicas; 1988.
5. Laplanche J, Pontalis JB. Vocabulário de psicanálise. São Paulo: Martins Fontes; 1985.
6. Heimann P. On counter-transference. Int J Psychoanal. 1950;31:81-4.
7. Bleger J. Temas de psicologia: entrevista e grupos. São Paulo: Martins Fontes; 1980.
8. Balint M. O médico, seu paciente e a doença. Rio de Janeiro: Atheneu; 1975.
9. Jeammet P, Reynaud M, Consoli S. Manual de psicologia médica. São Paulo: Masson; 1982.
10. Seguin CA. La enfermedad, el enfermo y el médico. Madrid: Pirámide; 1982.
11. Botega NJ, Silveira IU, Mauro MLF. Telefonemas na crise: percursos e desafios na prevenção do suicídio. Rio de Janeiro: ABP; 2010.
12. Freud S. Edição standard das obras psicológicas completas de Sigmund Freud. 2. ed. Rio de Janeiro: Imago; 1987. v. 11.
13. Botega NJ. No hospital geral: lidando com o psíquico, encaminhando ao psiquiatra [tese]. Campinas: Faculdade de Ciências Médicas, Universidade Estadual de Campinas; 1989.
14. Raimbault G. El psicoanálisis y las fronteras de la medicina. Barcelona: Ariel; 1985.
15. Millan LR, De Marco OLN, Rossi E, Arruda PV. O universo psicológico do futuro médico. São Paulo: Casa do Psicólogo; 1999.
16. Hoirisch A. O problema da identidade médica [tese]. Rio de Janeiro: Faculdade de Medicina, Universidade Federal do Rio de Janeiro; 1976.
17. Maltzberger JT, Buie DH. Countertransference hate in the treatment of suicidal patients. Arch Gen Psychiatry 1973; 30:625-33.
18. Yalom, ID. Os desafios da psicoterapia: reflexões para pacientes e terapeutas. Rio de Janeiro: Ediouro; 2006.
19. Ferrari H. Interconsulta y funcionamiento institucional. Acta Psiquiatr Psicol Am Lat. 1974;20(1):51-7.
20. Ferrari H, Luchina N, Luchina IL. La interconsulta médicopsicológica en el marco hospitalario. Buenos Aires: Nueva Visión; 1977.
21. Ferrari H, Luchina N, Luchina IL. Asistencia institucinal: nuevos desarrollos de la interconsulta médicopsicológica. Buenos Aires: Nueva Visión; 1979.
22. Bion WR. Experiências com grupos. Rio de Janeiro: Imago; 1970.
23. Amado G, Guittet A. A dinâmica da comunicação nos grupos. Rio de Janeiro: Zahar; 1978.

24. Grinberg L, Langer M, Rodrigué E. Psicoterapia de grupo. Rio de Janeiro: Forense-Universitária; 1976.
25. Kretschmer E. Psicología médica. Mexico: Leyenda; 1945.
26. Balint M. Psicanálise e prática médica. In: Missenard A, editor. A experiência Balint: história e atualidade. São Paulo: Casa do Psicólogo; 1994.
27. Missenard A, editor. A experiência Balint: história e atualidade. São Paulo: Casa do Psicólogo; 1994.
28. Nobre de Melo AL. Psiquiatria. 3. ed. Rio de Janeiro: Guanabara-Koogan; 1981.
29. Eizirik CL. Ensinando uma profissão impossível. Bol Psiquiatr. 1994;27(1):14-6.
30. Botega NJ. O ensino de psicologia médica no Brasil: uma enquete postal. Rev ABP-APAL. 1994;16(2):45-51.



Pacientes-problema: um impasse

Neury José Botega

Em capítulo anterior, fez-se um esboço do que se entende por personalidade, mecanismos de defesa e *coping*, a fim de auxiliar no entendimento de algumas reações no aparecimento de doenças somáticas e consequente hospitalização. Aqui, para compreender certos pacientes de difícil manejo, examinamos como certas modalidades de apego, traços de personalidade e mecanismos de defesa primitivos condicionam seus comportamentos. Quando uma pessoa desorganizada e desorganizante, em termos afetivos e comportamentais, encontra-se na enfermaria, a equipe precisa reunir-se para conversar e, ao final, tomar as principais decisões de manejo.

De modo geral, o que consideramos como pacientes-problema é, de um lado, decorrência da crise que se instala em pessoas que têm certos traços de personalidade e, de outro, da crise que acomete vários membros da equipe assistencial. Por não se ajustarem ao papel de doente, à rotina de cuidados e às regras do hospital, alguns pacientes passam a representar uma carga emocional para os que deles cuidam, emperrando a tarefa assistencial.

A desadaptação ao estresse e as reações anômalas diante das limitações decorrentes do adoecimento e da hospitalização tornam crítica a interação desses pacientes com a maioria dos membros da equipe assistencial. Quatro tipos de pacientes foram descritos por Groves.¹ Todos manifestam tendência à dependência psíquica. Seu comportamento provoca reações de raiva, evitação, desconfiança e desalento:

- **Dependente insaciável.** Parece agarrar-se aos que dele se aproximam. Não suporta ser deixado sozinho. É demasiadamente sensível ao que interpreta como descaso ou rejeição. A equipe assistencial tende a se esquivar.
- **Reivindicador arrogante.** Ao mesmo tempo que demanda atenção, faz comentários hostis e depreciativos. Tal comportamento esconde sentimentos subjacentes de desamparo e de temor relacionados ao adoecimento. A equipe assistencial tende a “contra-atacar”.
- **Rejeitador.** Ele pede cuidados, mas é pessimista em relação ao tratamento que recebe, “nada deu, dá ou dará certo”. Acaba minando o tratamento e a relação com a equipe assistencial. Ele quer estar próximo, mas, ao mesmo tempo, deixa os profissionais a distância e impotentes. A equipe assistencial fica ansiosa e irritada, além de se frustrar e até duvidar da própria capacidade.
- **Autodestrutivos.** Ao mesmo tempo que são dependentes e não cooperativos, envolvem-se em comportamentos autodestrutivos e não aderem ao tratamento. A equipe se desanima, ou se enraivece, ao ver todos os seus esforços desperdiçados diante de uma pessoa que não consegue conter a destrutividade.

TEORIA DO APEGO APLICÁVEL A SITUAÇÕES DE DOENÇA

A partir do fim da década de 1960, John Bowlby, um psiquiatra e psicanalista britânico, dirigiu sua atenção à reação de crianças que eram separadas de seus pais, quando hospitalizadas. Suas observações tomaram corpo na formulação da teoria do apego.²

Para Bowlby,³ o sistema de apego é inato, permitindo aos mamíferos maximizar a chance de sobrevivência de um filhote que nasce sem maturidade para viver de forma independente. Em uma visão etológica, o apego pode ser entendido como regulador do equilíbrio entre a segurança, por um lado, e a exploração e o lúdico, por outro. Estudos longitudinais demonstraram que o sistema de apego se mantém estável e ativo ao longo da vida.

Além da influência genética, padrões comportamentais sofrem a influência dos efeitos ambientais, notadamente da interação com um cuidador principal (figura de apego), que geralmente é a mãe. Os adultos-chave agem como uma base segura a partir da qual se explora o ambiente e também como um porto seguro para o qual voltar, quando o filhote é ameaçado ou precisa de proteção.

Dessa forma, a figura de apego tem função dupla: proteger do perigo imposto pelos predadores e funcionar como um apoio à vida independente, em momentos de segurança. O comportamento de apego é desencadeado em momentos de ameaça, quer pela percepção de ausência da figura primária de apego, quer pelo surgimento de um estímulo ameaçador.

Ao juntar elementos da psicologia cognitiva e da teoria psicanalítica (relações objetais), Bowlby³ propôs que as crianças pequenas internalizam suas experiências com figuras de apego para gerar modelos internos de funcionamento próprio, que modulam os relacionamentos com outras pessoas. Assim, cada modalidade de apego implica uma visão de si (*self*) e de outrem moldada a partir de experiências precoces com um cuidador.

Modalidades predominantes de apego já foram nomeadas e categorizadas de várias maneiras,⁴ e, com adaptações, algumas classificações visam ordenar padrões de resposta comportamental ante o adoecimento.⁵

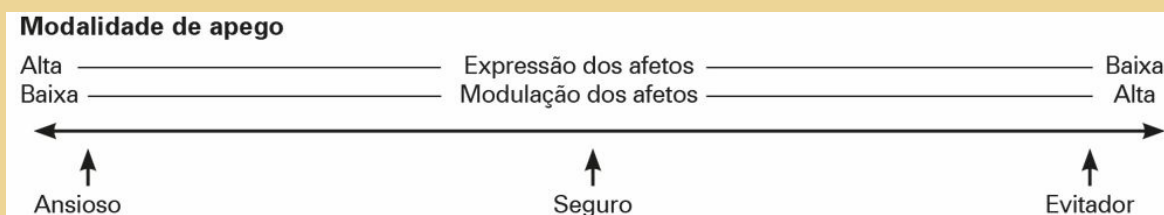
Devemos lembrar, no entanto, que a teoria do apego não fornece mais do que uma lente pela qual podemos ver, interpretar e iniciar propostas mais pragmáticas de manejo clínico. O significado singular do adoecimento só pode ser compreendido por meio de uma escuta ativa e de reflexão cuidadosas.

Feita essa ressalva, é preciso reconhecer que, por sua relativa simplicidade, a teoria do apego vem sendo muito aplicada em medicina psicossomática.⁶ Por ser de compreensão intuitiva, tem ampliado o entendimento do comportamento humano e permite, ao psiquiatra interconsultor, aplicar e ensinar, para a equipe assistencial, estratégias de como lidar com pessoas que acabam produzindo um impasse nos relacionamentos e na tarefa assistencial.

O Quadro 4.1 contém uma proposta de categorização das modalidades de apego ao longo de um *continuum*.⁷ Um instrumento de pesquisa condizente com essa proposta foi desenvolvido⁸ e testado em uma grande amostra populacional,⁹ a qual mostrou que aproximadamente 55% das pessoas têm uma modalidade de apego seguro. A mesma pesquisa estimou que 20% têm apego inseguro ansioso (um valor que decai ao longo dos anos), e 15%, apego inseguro evitador.

QUADRO 4.1

Um modelo em *continuum* de modalidades de apego



Características clínicas

Não acredita ser capaz de lidar com a doença	Tem autoconfiança e capacidade para suportar estresse (resiliência)	Autoconfiante, prefere contar consigo
Não mantém a calma inicialmente apresentada diante dos médicos	Mantém a expectativa positiva e confiança na equipe assistencial	Transmite a impressão inicial de que não haverá problemas
Dá sinais constantes de sofrimento a fim de assegurar cuidados, que sempre vê como insuficientes	Afetos expressados de forma que não sobrecarrega os cuidadores	Protegido por espécie de couraça, pouco demonstra dos afetos, rechaça cuidados
Dependência afetiva		Temor à dependência afetiva
Relato com detalhismo emocionado e incoerente, lapsos de memória	Descrição coerente e consistente dos problemas	Relato pouco informativo, vago, desprovido de afeto condizente
A preocupação com o próprio desespero impede colocar-se no lugar do outro	Forte capacidade reflexiva, capacidade de se colocar no lugar do outro	Pouca capacidade empática, não percebe necessidades de outrem
Usa vários artifícios para manter todos a seu lado: seduz, solicita muito, reclama, implora, ameaça	Solicita e beneficia-se de ajuda de modo a não criar conflitos com a equipe	Receber atenção é ameaçador, rechaça, descumprir, faz do seu próprio jeito
Equipe percebe o exagero e passa a se opor a pedidos de atenção	Equipe sente-se tranquila	

Sugestões de manejo

Mundo interno revolto e amedrontado necessita de REGULAÇÃO EXTERNA		Medo da dependência e aparente frieza necessitam de uma DISTÂNCIA ACEITÁVEL
Aceitar a dependência do paciente, em vez de confrontá-la		Aceitar a necessidade do paciente de manter o controle
Reconhecer as preocupações do paciente; em seguida, mostrar o outro lado (reenquadramento)		As respostas podem ser mais respeitadas, curtas e objetivas; sem “buscar” proximidade afetiva
Estabelecer limites		Buscar simetria e cooperação
Determinar um membro da equipe que centralizará comunicação e mostrará uma equipe preocupada, competente e unida		Se possível, permitir que o paciente estabeleça alguns parâmetros e objetivos de tratamento, a fim de diminuir resistência
Contatos mais frequentes e programados com o paciente		Discutir a conduta problemática do paciente reforçará a evitação
Pequenas reuniões de discussão da equipe ampliam compreensão e mantêm adequação das ações		Caso necessário, incentivar a detecção e exemplificação de estados afetivos (talvez por escrito)
Medicação ansiolítica pode auxiliar “regulação externa”	Observação: ver texto sobre modalidade de apego desorganizado	Certa flexibilidade para se adequar a necessidades do paciente poderá diminuir sua rigidez autoprotetora

Fonte: Com base em Hunter e Maunder.⁷

Pessoas com **apego inseguro ansioso** não desenvolveram a segurança que lhes permite enfrentar com ponderação uma situação de doença; recorrem ao auxílio dos outros, fazendo-o de

forma exagerada e compulsiva. A hipótese é a de que esse constante sinal de desespero (*care-seeking behavior*), emitido desde o início do desenvolvimento, é a única forma conhecida de obter atenção de uma figura de apego.

Pessoas com **apego inseguro evitador** tiveram a experiência, ao longo do desenvolvimento, de receber atenção de forma distante e pouco cuidadosa. Assim, suas necessidades não foram atendidas de forma a lhes transmitir confiança. Passaram, então, a não acreditar que outras pessoas pudessem ajudar pragmaticamente e emocionalmente. De modo reativo, passaram a contar apenas consigo mesmas. Por terem deixado de expressar seus sentimentos e emoções, essas pessoas podem parecer frias ou altamente controladas.⁷

Apego desorganizado (e desorganizante)

O exposto no Quadro 4.1 não deve ser tomado como uma classificação rígida e superficial das pessoas. A maioria, mas não todas as pessoas, poderia ser colocada em algum ponto do *continuum*. Os autores que esboçaram esse esquema unidimensional referem-se a uma terceira modalidade – a do apego desorganizado – que não pode aí ser encaixada.

No **apego desorganizado**, a pessoa manifesta intensa instabilidade, repetidamente varia de um polo a outro do *continuum* ou apresenta uma combinação dos dois extremos. Os afetos são tão flutuantes quanto intensos, e, ao mesmo tempo que ela anseia avidamente por cuidados, pode encarar a aproximação como uma ameaça, comportando-se com desconfiança e evitação.

Tende a ser incoerente, com pouca capacidade de se colocar empaticamente no lugar do outro. Parece viver sempre em crise, uma condição que se agrava na emergência de uma doença e de internação hospitalar.

Esse tipo de paciente pressiona a equipe assistencial constantemente. Quando não atendido em suas demandas, pode se tornar hostil, chegando à agressividade. Essa é a única maneira que encontra para lidar com a frustração. No entanto, quando atendido, pode exclamar algo do tipo “mas é só isso que vocês sabem fazer?” ou “isso nunca vai dar certo”. Essa dupla mensagem (pede ajuda/rejeita ajuda) frequentemente provoca antipatia.

Diante de pacientes com modalidade desorganizada de apego, a equipe assistencial também pode se desorganizar e deixar de se interessar por ser tão difícil de se relacionar. Alternativamente, para compensar a falta de aliança terapêutica, e respondendo às pressões para se empenhar mais, o médico pode assumir postura de muito fazer (pedindo vários exames, fazendo reavaliação diagnóstica) com receio de ter deixado passar algo. Se não parar para refletir, deixará de atuar terapêuticamente e, por atos ou omissões, terminará por confirmar as acusações e os temores do paciente.

Quando uma pessoa tão desorganizada e desorganizante encontra-se na enfermaria, a equipe precisa se reunir para conversar e, ao final, tomar as principais decisões. Para não se perder, deverá manter, acima de tudo, o bom padrão de atendimento dispensado aos pacientes em geral. Em algum momento, será útil lembrar que essa pessoa tão perturbadora não tolera a solidão, que é vivenciada como um desamparo angustiante. Ao mesmo tempo que se encontra desesperada por contato, não consegue confiar nas pessoas.

Traços de personalidade associam-se a padrões característicos de resposta comportamental, modulando a maneira como uma pessoa pensa, sente e se relaciona com os outros. Se esses traços forem marcantes, fixos e inflexíveis, causarão problemas nos relacionamentos interpessoais e no desempenho de funções sociais.

Há várias características associadas a esse tipo de paciente, a saber: a pessoa parece “se grudar” nos outros e nada a sacia, não tolerando poucos minutos de solidão; a arrogância e a demanda por cuidados são marcantes, com uma variedade de pequenas e grandes exigências; os esforços da equipe assistencial não são reconhecidos; o paciente divide os membros da equipe entre “bons” e “maus” e entre eles semeia a discórdia; passa a ser temido pela sua constante instabilidade e impulsividade; solicitações de interconsulta revelam, já na própria redação do pedido, um tom confuso, angustiante, exasperado, culposos ou derrotista. Quando isso ocorre, deve-se pensar na possibilidade de o paciente em questão sofrer de um transtorno mental, provavelmente de um transtorno da personalidade (Quadro 4.2).

QUADRO 4.2

Transtornos da personalidade do DSM-5

Grupo A: Características estranhas ou excêntricas

- Transtorno da personalidade paranoide
- Transtorno da personalidade esquizoide
- Transtorno da personalidade esquizotípica

Grupo B: Características dramáticas, emocionais ou erráticas

- Transtorno da personalidade antissocial
- Transtorno da personalidade limítrofe (*borderline*)
- Transtorno da personalidade histriônica
- Transtorno da personalidade narcisista

Grupo C: Características ansiosas ou temerosas

- Transtorno da personalidade evitativa
- Transtorno da personalidade dependente
- Transtorno da personalidade obsessivo-compulsiva

Fonte: Com base em American Psychiatric Association.¹⁰

Algumas das características encontradas nesses pacientes costumam dificultar ou impedir a adaptação, como desconsideração pelo próximo, violação de regras de convívio social, repetidas acusações e ameaças, dependência excessiva, comportamento impulsivo, tendência a manipular as pessoas, egocentrismo, instabilidade na autoimagem, nos afetos e nas relações interpessoais, grandiosidade, necessidade de admiração, incapacidade de estabelecer um relacionamento empático.¹¹

Nem todos os indivíduos com transtorno da personalidade são pacientes-problema. Geralmente, as dificuldades ocorrem em casos de transtornos de tipo antissocial, narcisista ou *borderline*, acompanhados ou não de comorbidade psiquiátrica, como uso abusivo ou dependência de álcool e de outras drogas psicoativas, depressão e transtorno de ansiedade.¹²

Indivíduos com transtorno da personalidade *borderline* conformam-se ao paradigma de paciente-problema (Quadro 4.3). Sua conduta acaba por provocar estragos na boa relação terapêutica, algo que eles tanto reivindicam.^{13, 14}

QUADRO 4.3

Critérios diagnósticos para transtorno da personalidade *borderline*

Um padrão marcante de instabilidade nos relacionamentos interpessoais, autoimagem e afetos, e acentuada impulsividade, que começa no início da idade adulta e está presente em uma variedade de contextos, como indicado por 5 (ou mais) dos seguintes critérios:

- Esforços frenéticos para evitar um abandono real ou imaginado.
- Um padrão de relacionamentos interpessoais instáveis e intensos, caracterizado pela alternância entre extremos de idealização e desvalorização.
- Perturbação da identidade: instabilidade acentuada e persistente da autoimagem ou do sentimento de si mesmo.
- Impulsividade em pelo menos duas áreas potencialmente prejudiciais à própria pessoa (por exemplo, gastos financeiros, sexo, abuso de substâncias, direção imprudente, compulsão alimentar).
- Recorrência de comportamento, gestos ou ameaças suicidas ou de comportamento automutilante.
- Instabilidade afetiva devido a uma acentuada reatividade do humor (por exemplo, episódios de intensa disforia, irritabilidade ou ansiedade, geralmente durando algumas horas e apenas raramente mais de alguns dias).
- Sentimentos crônicos de vazio.
- Raiva inadequada e intensa, ou dificuldade em controlar a raiva (por exemplo, demonstrações frequentes de irritação, raiva constante, lutas corporais recorrentes).
- Ideação paranoide transitória e relacionada ao estresse ou graves sintomas dissociativos.

Fonte: Com base em American Psychiatric Association.¹⁰

As defesas psicológicas utilizadas por pessoas que têm transtorno da personalidade são consideradas mais primitivas, características de um ego imaturo (Quadro 4.4).

QUADRO 4.4

Mecanismos de defesa primitivos em pacientes internados no hospital geral

- **Clivagem (*Splitting*).** Separação completa de ideias opostas, juntamente com os sentimentos a elas associados. Membros da equipe são divididos entre “bons” e “maus”. Paciente não concebe a ambivalência, reconhecendo que seres humanos têm limites, com “boas” e “más” qualidades presentes em uma mesma pessoa.
- **Identificação projetiva.** O paciente encara o cuidador dentro da seguinte “lógica”: “Eu sou mau e você cuida de mim, então você deve ser detestável: se não o fosse, não cuidaria de mim”. O cuidador pode, inconscientemente, passar a agir dentro dessa lógica, com hostilidade, ou sensação de desamparo e desesperança.
- **Negação psicótica.** O paciente expulsa da consciência algum aspecto angustiante de sua realidade, substituindo-o por outro, de caráter oposto: ele pode negar a gravidade de sua doença e pedir alta do hospital onde poderia ser tratado.
- **Idealização primitiva.** Tendência a conceber o médico ou outro profissional como alguém extremamente “bom”, a fim de proteger-se dos “maus” profissionais da equipe ou dos perigos da doença.
- **Onipotência e ataques.** A relação com uma equipe vista como poderosa, com poderes mágicos (idealização), pode cair por terra diante da primeira frustração. A equipe passará, então, a ser odiada, encarada como impotente.

Fonte: Groves¹ e Vaillant.¹⁵

O psiquiatra interconsultor é o profissional mais experiente para lidar com o impasse na relação entre o paciente e a equipe assistencial, quer pelas ações que pode realizar junto ao paciente, quer pela disponibilidade e as recomendações transmitidas à equipe assistencial

(Quadro 4.5). Enquanto a equipe geralmente o espera com ansiedade, o paciente, frequentemente, não o recebe de bom grado (“Os outros, não eu, é que precisam de psiquiatra”).

QUADRO 4.5

Ações do interconsultor junto ao paciente e à equipe assistencial

Comportamento do paciente	Ação junto ao paciente	Ação junto à equipe assistencial
Inadequação à realidade da doença e às regras do hospital, negação e demandas exageradas	Avaliar a presença de transtornos cognitivos. Avaliar a necessidade de medicação e de restrição. Auxílio na discriminação da realidade.	Auxiliar a equipe a compreender o comportamento do paciente. Ensiná-los a ajudar o paciente a adequar-se à realidade.
Comportamento autodestrutivo, ameaças de suicídio	Avaliar fontes de estresse, risco de suicídio e de comportamento violento.	Recomendar meios de contenção social, física e farmacológica necessários à segurança do paciente.
Dependência excessiva	Esclarecer que nem todas as demandas poderão ser atendidas.	Dar permissão para dizerem “não” às solicitações excessivas ou fora da realidade.
Rejeição aos esforços de tratamento	Respeitar certo distanciamento de que o paciente necessita. Repetidamente, reconhecer os direitos do paciente e solicitar a “colaboração espontânea”.	Diminuir sentimentos de depressão e de culpa, reconhecendo a impossibilidade de sempre satisfazer o paciente.
Manipulador (dependência e rejeição)	Estabelecer, de forma bem objetiva, firmes limites. Inteirar-se dos interesses manifestados pelo paciente.	Reconhecer os sentimentos de raiva da equipe, compreendendo-os, mas conter retaliações sádicas sobre o paciente.

Fonte: Com base em Groves.¹²

Em geral, a intervenção do psiquiatra pode ser dividida em três fases:

- O paciente deve ser ouvido atenta e respeitosamente, sem crítica.
- Ele deve ser auxiliado a reconhecer as limitações impostas pelo tratamento e pelo ambiente hospitalar. Isso deve ser feito de maneira firme, sem agressividade e sem um sentido de punição.
- A equipe assistencial precisa ser ouvida e compartilhar suas impressões com as do psiquiatra, participando das principais decisões em relação ao manejo do paciente.

MINIRREUNIÃO CLÍNICA

A necessidade de uma reunião com o psiquiatra em geral não é explícita. Somos nós que a inferimos a partir de um padrão de comportamento – logo que chegamos à enfermaria ou ao fim do contato com o paciente, colocamo-nos à disposição para ouvir quem solicitou nossa avaliação. Naturalmente, vários membros da equipe vão se aproximando, ávidos por participar da conversa. Então, lançamos a ideia: “Que tal nos reunirmos a tal hora, por alguns minutos, para pensarmos juntos sobre essa situação?”.

O psiquiatra interconsultor costuma ser o catalisador que consegue reunir profissionais atarefados em pequenas e rápidas reuniões de 30 minutos. Tem-se a experiência de organizar esses encontros, geralmente no fim da manhã, com os membros da equipe assistencial que estejam disponíveis.

Deve-se conversar sobre duas coisas importantes, a saber: como estão se sentindo e quais as estratégias a serem adotadas no manejo do paciente. Essa conversa é importante, pois os sentimentos, geralmente turbulentos diante de um paciente difícil, precisam ser compartilhados e acalmados. Temos de transformar em pensamentos e compreensão o que nos deixa tão exasperados e confusos.

Didaticamente, podemos pensar que a “minirreunião” deve ser dividida em três partes, de mesma duração, em termos aproximados. A primeira parte deve ocupar aproximadamente um terço do total de tempo – será a fase dos desabafos, das comparações, das dúvidas, etc. Ninguém pode monopolizar; é importante todos se expressarem, inclusive os que costumam ser mais calados. O profissional deve cuidar disso, solicitando um colega prolixo para concluir; abrindo a palavra para quem gesticula discordando; perguntando o que acham do que foi dito; garantindo que o outro lado expresse seu ponto de vista; e destacando expressões verbais ou chistes que provocaram *insight* (repara-se nisso pelas expressões não verbais: todos concordam, geralmente com sorrisos e descontração corporal, e segue-se um momento de alívio ou mudança de assunto).

A segunda parte do tempo da reunião é dedicada a esclarecimentos e troca menos acalorada de ideias. A catarse inicial costuma ceder espaço para considerações menos raivosas e mais compreensivas. Podemos, também, propor um “pinga-fogo”, por meio do qual cada participante terá de 30 a 60 segundos para dizer algo que julgue importante no contexto da reunião.

Faltando 10 minutos para o término, na terceira parte da reunião, deverá haver tomada de decisões. A reunião deverá ser encerrada, retomando-se, sinteticamente, as principais medidas a serem tomadas, de preferência com a concordância de todos. Deve ficar claro que as decisões da reunião deverão ser respeitadas; ninguém poderá alterá-las sozinho. Todos devem zelar pelo cumprimento das regras estabelecidas, falar a mesma linguagem e não se dividir, perante o paciente, entre *maus* e *bonzinhos*.

Após a minirreunião, a equipe assistencial fica com a tarefa de, diariamente, se reunir por alguns minutos, a fim de alcançar um consenso sobre como proceder com coesão e firmeza diante de situações criadas pelo paciente.

Um porta-voz

O paciente entra em pânico quando não identifica aliados. Idealmente, um profissional que se sinta mais tranquilo e no controle da situação deve ser o porta-voz da equipe assistencial. Quando isso não for possível na prática, recomendamos que, no início de cada turno, um profissional se apresente, pergunte como as coisas estão caminhando, ouça um pouco o paciente, reforce algumas recomendações, diga por quanto tempo permanecerá naquele turno e de que forma pretende dedicar-se ao paciente. Apenas quando possível (em casos mais graves isso não é recomendável), pode-se negociar algumas combinações.

Intervenção verbal em dois tempos

O paciente aferra-se a seus direitos e prerrogativas, pois teme a situação ameaçadora em que se encontra. Por fazer muitas exigências, enerva a equipe. É aconselhável não entrar em confronto franco com o paciente, ainda mais se estiver movido por raiva.

Em vez disso, deve-se procurar fazer uma intervenção em dois tempos. Primeiro, reconhecer as necessidades e os incômodos por que o paciente passa, garantindo que ele merece toda a atenção. Após esse reconhecimento, geralmente vem um “mas...”, acrescentando o outro lado da moeda. Deve-se acrescentar que, para o próprio bem dele, serão seguidas as normas da enfermaria e as técnicas resultantes do conhecimento médico e da experiência da equipe. Serão, então, estabelecidos os limites. Veja um exemplo dessa intervenção no Quadro 4.6.

QUADRO 4.6

Exemplo de intervenção em dois tempos

Tempo 1: RECONHECIMENTO. Ouvir, com respeito e atenção, as dificuldades, os sentimentos e as opiniões expressados pelo paciente, como:

“Eu compreendo que é muito chato você ser impedido de sair do hospital para ir até o banco, principalmente diante dos motivos que você expôs e também porque, indiscutivelmente, sempre foi uma pessoa com total liberdade para fazer o que desejar...”

Tempo 2: LIMITE. Estabelecer, ou relembrar, as restrições que visam à sua proteção:

“... por outro lado, já conversamos sobre como está sua impulsividade e sua dificuldade para se controlar. A proibição de sair, além de temporária, é para protegê-lo. Por ora, colabore e aceite o que já combinamos!”

Diante de eventual inconformismo, responda com firmeza, mas, ao mesmo tempo, com delicadeza e respeito. Fale de forma concisa e não se alongue em justificativas. Valendo-se de frases curtas, seja objetivo e enfatize expressões, tais como: “por preocupação”, “para proteção”, “circunstancial”, “temporário”. Lembre-se: não entre em disputas verbais e não altere a voz.

Se o paciente se exasperar, interrompa e avise: “Eu quero continuar a ajudá-lo, mas você está muito nervoso. Eu vou me afastar por um minuto para você poder se acalmar. Em seguida, a gente volta a conversar”. E afaste-se calmamente, sem menosprezo nem raiva.

A intervenção verbal em dois tempos é uma estratégia útil para lidar com exigências pouco razoáveis vindas de uma pessoa “geniosa”. Ela também pode ser adotada, de modo geral, na comunicação empreendida com pessoas que, por estarem mergulhadas em uma crise, regredem emocionalmente e se tornam exigentes demais.

A forma sugerida para lidar com o conflito pode ser treinada durante a reunião, por meio de uma rápida dramatização (*role-playing*), que deve se dar a partir de uma situação concreta trazida à reunião da equipe assistencial.

Os limites colocados pela equipe assistencial (por um porta-voz) auxiliam o paciente que funciona primitivamente a alcançar maior controle interno. Deve-se evitar, no entanto, o confronto, de acordo com as seguintes recomendações:¹⁶

- Reconhecer os estresses pelos quais o paciente está passando
- Respeitar os mecanismos de defesa dos quais ele lança mão
- Evitar o estímulo às demandas por cuidados e proximidade
- Não desafiar ou incitar o paciente a reações de raiva
- Evitar confrontar as prerrogativas que o paciente narcisisticamente atribui a si mesmo.

É preciso atentar para sinais que indicam a iminência de uma explosão de violência, como exigências feitas de modo crescente e veemente, manifestação de raiva, linguagem inadequadamente hostil, inquietude motora, ideação paranoide ou medo da equipe. Nos casos em que as ameaças do paciente denunciarem a iminência de comportamento violento, colocando em risco sua integridade ou a dos outros, devem ser tomadas providências, como sedação (ver Cap. 13, sobre agitação psicomotora).

Além do risco de violência contra terceiros, é imprescindível avaliar o risco de suicídio, considerando as características associadas a maior risco (agitação psicomotora, principalmente se acompanhada de períodos de confusão mental, desespero diante do diagnóstico ou prognóstico da doença, tentativa de suicídio prévia, comorbidade com outros transtornos psiquiátricos, como depressão e dependência de substâncias psicoativas).

É importante lembrar que casos de suicídio em hospital geral se dão menos por depressão e mais por desespero ou *delirium*. Podem ocorrer, também, em resposta a sentimentos de intenso desamparo e raiva, ocasionados por um desentendimento e rompimento com algum ente querido ou mesmo com um membro da equipe assistencial (ver Cap. 16, sobre comportamento suicida).

Relembramos que estamos tratando aqui de pacientes que têm transtornos da personalidade ou traços fortemente assemelhados a eles. No capítulo precedente, observamos que, no caso de pacientes cuja ansiedade e o nível de exigência derivam da necessidade de controle (perdida em decorrência da doença e da internação), a conduta deve ser outra. Ver, por exemplo, o comentário sobre pessoas que têm personalidade tipo A, no Capítulo 2.

Alguns pacientes com traços paranoides, que vivenciam a situação de dependência e passividade como algo ameaçador, projetam sua raiva e desconfiança nos que deles se aproximam, forçando-os a reagirem agressivamente. Assim, poderão continuar agressivos, no controle, sem a angústia de quem se sente submetido, amedrontado e desamparado.

Em *Psychiatric Consultation in the General Hospital*, Glickman¹⁷ reúne observações agudas e espirituosas sobre casos de interconsulta. Cita, por exemplo, o caso de um paciente de 45 anos que tinha sofrido infarto agudo do miocárdio e de quem se suspeitava um intenso conflito na área de identificação sexual. Ele criava animosidades, recusava-se a cooperar, denegria os conhecimentos e esforços da equipe assistencial para ajudá-lo e se negava terminantemente a aceitar as restrições impostas pelo ambiente hospitalar. Em vez de, simplesmente, aconselhar a equipe a não agredir o paciente, tratando-o com respeito e firmeza, o autor recomenda o seguinte:

Elogiem o fato de o paciente ter apreendido corretamente como se encontra o conhecimento médico a respeito de sua situação. Enfatizem como deve ser grande a determinação de um homem para conseguir submeter-se às restrições de dieta, fumo e deambulação. Deixem claro para o paciente que vocês compreendem como as proibições que lhe estão sendo impostas são difíceis de serem aceitas, que só um homem determinado como ele poderia aderir a tal tratamento.¹⁷

Com humor, Glickman sugere que, em vez de se fazer uma preleção técnica inteira, a história que pode ser contada ao médico e à equipe assistencial, no intuito de auxiliá-los a compreender a psicodinâmica do caso, é a do masoquista que implora ao sádico “Me bata!”, e o sádico responde “Não!”.

Alta a pedido

Transtornos psiquiátricos e certos traços de personalidade podem estar relacionados à solicitação de alta e se encontram resumidos no Quadro 4.7.

QUADRO 4.7

Condições psiquiátricas, com respectivos sintomas, relacionadas à “alta a pedido”

Dependência de substâncias psicoativas	O desejo de consumir álcool ou drogas leva o paciente a querer sair precocemente do hospital. Pode haver, também, impulsividade, agressividade, com deterioração da cognição e do julgamento
Transtornos psicóticos paranoides	Distorções da realidade (médico = inimigo; remédio = veneno), desconfiança, especialmente com figuras de autoridade.
Mania	Sentimento de grandiosidade e de invencibilidade. É possível haver exasperação e agressividade.
Demência e delirium	Desorientação, déficit mnêmico, estranhamento do ambiente, falta de pessoas conhecidas.
Transtorno da personalidade <i>borderline</i>	Instabilidade emocional, suscetibilidade a mudanças no ambiente, capacidade limitada para tolerar frustrações, principalmente isolamento, dificuldades nas relações interpessoais, comorbidade psiquiátrica.
Transtorno da personalidade antissocial	Impulsividade, transgressão de normas, delitos e outras faltas.
Transtorno da personalidade narcisista	Sentimento de autoimportância, falta de empatia, negação das limitações atuais.
Transtorno da personalidade passivo-dependente	O tratamento pode entrar em crise quando são cobradas do paciente autonomia, participação e responsabilidade.

Fonte: Com base em Duñó Ambrós e Sans Torres.¹⁸

Segundo trabalhos norte-americanos, a interconsulta psiquiátrica consegue demover de sua intenção 25 a 35% dos pacientes que solicitam alta hospitalar, ao contrário da recomendação da equipe médica.¹⁹⁻²⁰ Quando chamado, o psiquiatra deve obter, como em toda interconsulta, informações do paciente, dos membros da equipe assistencial e de familiares, a fim de formular um diagnóstico situacional.

Na fase de avaliação do caso, três perguntas devem estabelecer o norte:

1. Quais são as razões por que o paciente exige sua alta?
2. O paciente tem um transtorno mental?
3. O paciente, do ponto de vista legal, pode ser considerado capaz de tomar essa decisão? (A avaliação da capacidade para recusar tratamentos é aprofundada no Cap. 28.)

HOSPITALISMO

O termo “hospitalismo” tornou-se mais conhecido após os trabalhos de Spitz,²¹ referindo-se a quadros de apatia e depressão (depressão anaclítica), nos primeiros dois anos de vida, em crianças que se encontravam em instituições, com privação de maternagem. Em nosso meio, o termo é utilizado para se referir a quadros de repetidas reinternações ou de permanência hospitalar além da média prevista para o quadro clínico, nos quais há o desejo consciente ou inconsciente de o paciente ser cuidado emocionalmente, mediante agravo e prolongamento de queixas físicas ou psicopatológicas.

Os benefícios obtidos com essa situação abarcam os cuidados recebidos no ambiente hospitalar, bem como a legitimação do papel de doente junto a familiares e pessoas mais próximas. Não se incluem nessa concepção os casos em que a reinternação ou a permanência prolongada devem-se à falência do sistema de saúde, ao mau gerenciamento institucional, ao abandono familiar, à manutenção da internação por interesse científico ou às internações que se dão sob forte pressão institucional, ainda que essas condições possam contribuir para o que se trata aqui por hospitalismo.²²

Esses pacientes, às vezes, deixam o hospital para retornar algumas horas mais tarde ou no dia seguinte.^{23,24} Em geral, são pacientes de idade mais avançada, acometidos por doenças invalidantes crônicas, que apresentam, frequentemente, transtornos psiquiátricos e problemas psicossociais (família, moradia, trabalho, finanças, etc.). Os critérios operacionais para um diagnóstico psiquiátrico nem sempre são preenchidos.

Para a consternação da equipe assistencial, é frequente o agravo do quadro clínico às vésperas da alta hospitalar – ocasião que provoca insegurança e exigências de pacientes e de familiares, que passam, então, a se opor à alta. Essa oposição pode vir matizada de expectativas irreais em relação aos benefícios do prolongamento da hospitalização. Tal ocorrência pode ser evitada ou minimizada se, desde o início, pacientes e familiares forem bem informados a respeito do objetivo da internação e de como a continuidade do tratamento será dada em âmbito ambulatorial (Quadro 4.8).

QUADRO 4.8

Medidas que facilitam a aceitação da alta

- Informar o paciente, ao ingressar no hospital, sobre os objetivos da internação
- Manter uma boa relação médico-paciente-família
- Programar a alta com antecedência, transmitindo isso ao paciente e familiares
- Estar disponível para ouvi-los e ajudá-los em suas necessidades
- Prover atendimento especializado nos casos em que se detecta transtorno psiquiátrico
- Acionar o serviço social nos casos necessários

Há outros problemas, surgidos próximos da alta hospitalar, que desencadeiam solicitação de interconsulta psiquiátrica. Isso é abordado quando se trata do “caráter de urgência” da interconsulta. Pode ocorrer a percepção da família de que o paciente apresenta algum distúrbio de comportamento, até então não valorizado pela equipe assistencial. Ou, então, descobre-se que,

além de ter algumas dificuldades emocionais, o paciente não tem para onde ir, ou que sua família não reúne condições mínimas para lhe dispensar os cuidados necessários.

Nessas condições, é imprescindível a discriminação das responsabilidades comumente aceitas nos distintos campos profissionais do médico assistente, do psiquiatra e do assistente social (Quadro 4.9).

QUADRO 4.9

Áreas de responsabilidade nos problemas suscitados por ocasião da alta hospitalar

Médico assistente	Psiquiatra interconsultor	Assistente social
Desacordo com o cumprimento dos objetivos da internação	Transtornos psicopatológicos associados	Problemas sociais, familiares ou de moradia
Presença de transtornos físicos	Encaminhamento a serviços de psiquiatria	Encaminhamento a centros de apoio social

Fonte: Com base em Cañete Crespillo.²⁵

Um subgrupo de pacientes nos quais se observava o hospitalismo, com doença pulmonar obstrutiva crônica, foi mais bem estudado por Galizzi:²⁶ detectou-se a pressão familiar como principal desencadeante de repetidas internações. As famílias ficavam apreensivas e desestabilizadas com as constantes pioras do quadro respiratório. A cada reinternação, a instituição acabava por facilitar a perpetuação do problema, ao permitir que um novo médico assistisse o paciente. Há, nesses casos, a necessidade de um programa de atendimento, após a alta hospitalar, que inclua apoio ao paciente e a familiares, com visitas domiciliares, quando necessário.

REFERÊNCIAS

1. Groves JE. Taking care of the hateful patient. *N Engl J Med*. 1978;298(16):883-7.
2. Belsky J, Cassidy J. Attachment: theory and evidence. In: Rutter M, Hay DF, editors. *Development through life: a handbook for clinicians*. Oxford: Blackwell Science; 1994. p. 373-402.
3. Bowlby J. *Formação e rompimento de laços afetivos*. 5. ed. São Paulo: Martins Fontes; 2015.
4. Bartholomew K, Horowitz LM. Attachment styles among young adults: a test of a four-category model. *J Pers Soc Psychol*. 1991;61(2):226-44.
5. Maunder RG, Hunter JJ. Assessing patterns of adult attachment in medical patients. *Gen Hosp Psychiatry*. 2009;31(2):123-30.
6. Thompson D, Ciechanowski PS. Attaching a new understanding to the patient-physician relationship in family practice. *J Am Board Fam Pract*. 2003;16(3):219-26.
7. Hunter JJ, Maunder RG. Using attachment theory to understand illness behavior. *Gen Hosp Psychiatry*. 2001;23(4):177-82.
8. Hazan C, Shaver PR. Romantic love conceptualized as an attachment process. *J Pers Soc Psychol*. 1987;52(3):511-24.
9. Mickelson KD, Kessler RC, Shaver PR. Adult attachment in a nationally representative sample. *J Pers Soc Psychol*. 1997;73(5):1092-106.
10. American Psychiatric Association. *Manual diagnóstico e estatístico de transtornos mentais: DSM-5*. 5. ed. Porto Alegre: Artmed; 2014.
11. Wise MG, Rundell JR. *Concise guide to consultation psychiatry*. Washington: American Psychiatric; 1988.
12. Groves JE. Difficult Patients. In: Cassem NH, editor. *Massachusetts general hospital handbook of general hospital psychiatry*. Saint Louis: Mosby; 1997. p. 337-66.
13. Adler G. Helplessness in the helpers. *Br J Psychol* 1972;45(4):315-26.
14. Gunderson JG. The borderline patient's intolerance of aloneness: insecure attachments and therapist availability. *Am J Psychiatry*. 1996;153(6):752-8.
15. Vaillant GE. Theoretical hierarchy of adaptive ego mechanisms. *Arch Gen Psychiatry*. 1971;24(2):107-18.
16. Adler G, Buie DH. The misuses of confrontations with borderline patients. *Int J Psychoanal Psychother*. 1972;1:109-20.
17. Glickman LS. *Psychiatric consultation in the general hospital*. New York: Marcel Dekker; 1980.
18. Duñó Ambrós R, Sans Torres J. La inadaptación al hospital y el alta voluntaria. In: Rojo Rodes, JE, Cirera Costa, E. *Interconsulta Psiquiátrica*. Barcelona: Biblio STM; 1997. p. 571-5.
19. Schlauch R. Leaving the hospital against medical advice. *N Engl J Med*. 1979;300:22-4.

- Holden P. Patients who leave the hospital against medical advice. *Psychosomatics*. 1989;30:396-404.
20. 1989;30:396-404.
21. Spitz R. Anaclitic depression. *Psychoanal Study Child*. 1946;2:313.
22. Galizzi HR. Hospitalismo: diagnóstico psiquiátrico. *J Bras Psiquiatr*. 1994;43(7):373-6.
23. Williams EI, Fitton F. Factors affecting early unplanned readmission of elderly patients to hospital. *BMJ*. 1988;297(6651):784-7.
24. Rabinowitz J, Mark M, Popper M, Slyuzberg M, Munitz H. Predicting revolving-door patients in a 9-year national sample. *Soc Psychiatry Psychiatr Epidemiol*. 1995;30(2):65-72.
25. Cañete Crespillo J. La larga estancia, el hospitalismo y los problemas sociales. In: Rojo Rodes, JE, Cirera Costa, E. *Interconsulta Psiquiátrica*. Barcelona: Biblio STM; 1997. p. 577-80.
26. Galizzi HR. A rejeição ao paciente com internações repetidas no hospital geral. *Cadernos IPUB (Saúde Mental no Hospital Geral)*. 1997;6:185-94.



Relação entre médicos

Neury José Botega

No hospital geral, as situações nas quais o psiquiatra é chamado não se baseiam em uma problemática restrita ao paciente. Delas participam vários condicionantes de ordem pessoal, relacional e institucional. Sob um ponto de vista psicodinâmico, a interconsulta psiquiátrica presta-se tanto para a manutenção das defesas dos que prestam assistência quanto para romper um pacto de irreflexão e silêncio, buscando adaptações do médico em sua tarefa assistencial. Não só as condições clínicas do paciente, mas também as necessidades e os sentimentos do médico, modulam a relação com o especialista. No processo de encaminhamento, influem aspectos transferenciais e contratransferenciais da tríade formada por paciente, médico e especialista.

Neste capítulo, abordam-se alguns aspectos psicodinâmicos que modulam a relação entre o médico assistente e o psiquiatra chamado para a interconsulta. Trata-se de um modelo, uma nova proposta de entendimento dessa relação. Não é uma teoria exclusiva, nem é suficientemente abrangente. Ainda assim, acreditamos que o capítulo poderá dar subsídios para o entendimento das relações empreendidas entre profissionais da área da saúde.

O PSIQUIATRA INTERCONSULTOR

Nesse caldeirão [que é um hospital geral], não há lugar para tédio: o sofrimento pela doença é sempre intenso, o alívio e a alegria por uma cura conseguida (isso existe!), enormes, cada caso é como se fosse o primeiro, cada aula é um novo desafio, a construção de nossa identidade profissional está sempre por se fazer. Daí, talvez, as fontes de angústias e também da beleza desse ofício.¹

O psiquiatra descobriu que trabalhar no hospital geral é bem diferente de trabalhar em serviços psiquiátricos. Ele se encontra, de novo, “dentro” da medicina e tem de enfrentar situações novas, cuja solução geralmente não depende apenas de medidas técnicas. Seu alvo de trabalho deixou de ser o paciente apenas, passando a incluir a equipe médica e a instituição, buscando influir na formação teórica e na prática dos profissionais da saúde.

Para atuar nesse novo campo, é imprescindível a aquisição de conhecimento ampliado em psiquiatria clínica, como manifestações psíquicas de doenças orgânicas, efeitos de drogas no sistema nervoso central, interações medicamentosas, tratamento da depressão associada ou não a transtornos orgânicos, etc. Não menos importante é o conhecimento na área de psicologia médica e do funcionamento institucional, a fim de orientar o manejo de diversas situações, como tentativa de suicídio, reação psicológica à condição de enfermidade e dinâmica grupal.

A convivência entre as especialidades médicas e profissionais de saúde mental, no âmbito do hospital geral, implica redefinição de papéis e busca de identidade. Na realidade, o *papel* do psiquiatra nesse novo ambiente, em termos de atividades e atitudes que dele são esperadas, ainda não está bem delimitado. Lembremos que a cada papel corresponde uma expectativa, um modo esperado de comportamento. É o contexto social que regula a conformação desse papel, que age por meio de normas e valores dominantes, bem como por gratificações e sanções que o profissional recebe.²

No hospital geral, no entanto, pode não haver coincidência entre as necessidades (vistas pelos psiquiatras) e a demanda (solicitação de seus serviços). As expectativas das partes envolvidas podem, assim, ser frustradas. As tarefas do psiquiatra no hospital geral relacionam-se, primariamente, às respostas dadas por esse profissional às demandas vindas de algum membro da equipe assistencial. Seu papel vincula-se, portanto, às necessidades que são percebidas pela equipe assistencial.³ Ocorre que, muitas vezes, as necessidades detectadas pelo psiquiatra nem sempre são expressadas pela equipe assistencial, e pode haver solicitação de intervenções que, na visão do psiquiatra, não são prioritárias. Há, portanto, que se ter bem claro o que cada profissional espera do outro e o que cada um pode oferecer.

A aquisição de novos conhecimentos, aliada à atuação concreta do profissional junto a pacientes e colegas de outras especialidades, vai moldando um perfil diferente para o psiquiatra que se inicia no campo das interconsultas. Seu trabalho passa a ser marcado por um outro “trabalho”: interno, de elaboração de conflitos e de redefinição do papel profissional. Isso é ilustrado por trechos do relato de um residente de psiquiatria, que consta em uma monografia redigida ao término do estágio no serviço de interconsulta do Hospital de Clínicas da Universidade Estadual de Campinas (Unicamp).⁴ Por um tempo, ele acompanhou uma paciente

com leucemia mieloide aguda, no curso de um tratamento quimioterápico que não surtia bons resultados:

Saí daquele quarto com enjoos, querendo pôr para fora uma sensação de medo e dor, como há muito tempo não sentia. M.H. e seu sofrimento me acompanharam naquela noite... Com as dores de M.H. adormeci e, ao acordar, pude perceber claramente que as dores que eu trazia para casa eram minhas próprias dores diante do inexorável que é a perspectiva do morrer.

[...]

Foi entre assustado e triste que observei o cesto do lixo, quando voltei para visitar minha paciente. O esboço de sorriso da primeira entrevista desaparecera junto aos cabelos que agora repousavam no lixo. Ao seu lado, haviam instalado um monitor cardíaco. No braço, inchado e repleto de hematomas, muitas cânulas chegavam trazendo remédios e soro.

[...]

Já me acostumara com o rosto triste e sem sorriso, com a falta de cabelos e de palavras. Nossos encontros eram longos momentos de silêncio, interrompidos algumas vezes por perguntas e pedidos de ajuda.

[...]

A segunda quimioterapia não teve os resultados esperados. A médica que acompanhava o caso vem me procurar. Está aflita, diz que por essa não esperava. Combino uma reunião com algumas pessoas da equipe assistencial (dois médicos e dois alunos do internato que estão estagiando na Hematologia). A reunião ocorre, e eu continuo visitando minha paciente.

[...]

“Não me deixe morrer!”, diz M.H. numa sexta-feira às vésperas de um feriado. Mas eu não sou seu médico hematologista, tampouco Deus, pensei depois com raiva e tristeza.

[...]

Naquela noite, casualmente, me encontro com a médica que cuidava da paciente, no refeitório do hospital. Ela me perguntou o que eu havia feito, pois a paciente havia chorado toda a tarde. [...] Pude perceber que, em muitos momentos, eu falava de alguém que precisava de ajuda no caminho de morrer, e os colegas médicos falavam de uma possibilidade de aumentar seus meses de vida. Nessas ocasiões, percebia que eu representava o lado da morte, e os médicos mostravam o desejo de dar à paciente a vida.

[...]

Após a terceira quimioterapia, M.H. teve uma remissão do quadro que lhe dava uma sobrevida de aproximadamente um ano, segundo seus médicos [...]. Ela diz ter esperança, querer poder viver mais, “sobreviver”.⁴

Algumas questões fundamentais no trabalho do interconsultor depreendem das passagens citadas. Ele deve estar acostumado a lidar com manifestações da mente, pois, ao entrar em uma enfermaria de hospital geral, o psiquiatra é assaltado pela corporalidade tangível das doenças orgânicas. “Acostumados às dores da alma, nossos olhos assustados voltam-se para corpos que sentem dor, para uma morte concreta.”⁴

O contato do psiquiatra com pacientes da cirurgia e da clínica médica muitas vezes reacende suas ansiedades hipocondríacas – frequentes entre médicos e tão notáveis no tempo da graduação. Em situações como a vivida por esse médico residente, o interconsultor pode ter uma sensação de estranheza, de não ter referencial, como alguém que fora obrigado a sair de seu campo de atuação.

O psiquiatra interconsultor é um profissional que se introduz como observador participante de situações clínicas tocantes, podendo, eventualmente, tornar-se o depositário de poderosas ansiedades e reagir de forma inapropriada. Tem de enfrentar situações de dor, perdas e mutilações, situações de regressão psicológica, de ansiedades psicóticas e confusionais. Por isso, ele deve estar atento a identificações que possa fazer com as pessoas envolvidas em cada situação clínica da qual participa. A importância dessa questão está ligada à possibilidade de se

identificar tanto com os pacientes quanto com os médicos assistentes, ficando sua ação paralisada ou demasiadamente influenciada por seus sentimentos contratransferenciais.

[...] o novo campo de ação da interconsulta deve ser integrado por pessoas com uma formação muito especial, que inclua o haver estado expostas a situações psicóticas sumamente graves, assim como a situações médicas tão sérias como as que se encontram entre a vida e a morte de um paciente. E, por outra parte, para ocupar-se desta tarefa, [o interconsultor] deverá estar disposto a operar fora do contexto psicoterapêutico habitual, em um ambiente que, em geral, incrementa a frustração, o que imprime uma sobrecarga emocional adicional a sua tarefa.⁵

As ansiedades geradas no trabalho de interconsulta podem interferir na percepção do fenômeno que se pretende examinar, borrando os limites egoicos e descompensando as defesas psicológicas. Podem, no entanto, ser estímulos enriquecedores para o autoconhecimento, auxiliando o crescimento pessoal e profissional do interconsultor. Por essa razão, duas medidas são aconselháveis: 1) submeter-se à psicoterapia e 2) participar de reuniões com os profissionais da equipe de interconsulta, a fim de se intercambiarem sentimentos e experiência clínica.

Em um texto seminal, Mendelson e Meyer⁶ chamam a atenção para o que chamam de reações contratransferenciais do interconsultor. Trata-se não somente de reações aos fatos da vida e da morte de pacientes em particular, mas também da totalidade das transações interpessoais na enfermaria à qual o interconsultor chega.

Os sentimentos vivenciados constituem-se em uma amostra das tensões interpessoais atuantes na situação clínica. Se não forem discriminados e compreendidos, tais sentimentos poderão interferir de forma a prejudicar o desenrolar da interconsulta. Quatro situações são destacadas pelos autores que, frequentemente, provocam sensação de impotência, de raiva, negação, evitação, esquecimentos ou identificação excessiva com os pacientes, descritas a seguir.

As inconveniências físicas e psicológicas do trabalho em ambiente médico

Os pedidos de interconsulta têm caráter irregular e imprevisível. As instalações físicas de uma enfermaria em nada se parecem com as de um consultório especialmente montado para atender às necessidades do psiquiatra. A entrevista tem de ser realizada a despeito da falta de privacidade e, frequentemente, com interrupções. A comunicação pode ser dificultada pelas limitações impostas pela doença ou pelos recursos empregados em seu tratamento. O paciente pode não se encontrar disponível (exames, curativos, etc.) ou estar muito fatigado, dificultando a avaliação. Pode, também, estar muito pouco interessado em conversar com um psiquiatra.

A presença de doenças graves e o risco de morte

Essas condições podem contribuir para desencadear uma sensação de desalento no interconsultor. Cada um de nós tem seus conflitos e suas preocupações em relação ao adoecimento, a doenças crônicas e a situações de desamparo e de morte. Geralmente, os médicos não psiquiatras defendem-se de diversas maneiras dos sentimentos provocados por essas condições que fazem parte de sua prática diária. No entanto, pela própria natureza de seu trabalho, o interconsultor expõe-se mais e se aproxima emocionalmente dos pacientes, com

interesse pelo seu sofrimento e seu desespero. Ele precisa, em certa medida, identificar-se com - esses pacientes, a fim de compreendê-los melhor. É quando pode sentir-se desmotivado, pessimista e com a sensação de que, “no lugar do paciente”, estaria do mesmo jeito. No Capítulo 15, sobre depressão, comentamos como tal reação pode levar à falha diagnóstica e ao imobilismo terapêutico.

Dilemas e frustrações relacionados a pacientes de difícil manejo

Pacientes de difícil manejo acometidos por patologias orgânicas trazem muitas dificuldades para a equipe assistencial e para o interconsultor. Esses pacientes não se adaptam à internação, manifestam muito pouco interesse pelo tratamento e geralmente desprezam os esforços terapêuticos a eles dirigidos. Pode haver casos em que a passividade, a dependência ou traços paranoides são as características marcantes da personalidade, dificultando, igualmente, o manejo. Esses pacientes costumam provocar, na equipe assistencial, muita frustração, raiva e desestímulo. Também costumam deixar o interconsultor incerto quanto aos objetivos e limites de sua atuação. Veja, sobre esse assunto, o Capítulo 4, sobre “pacientes-problema”.

Condições de miséria e de desagregação familiar

Comumente avaliamos pacientes que não terão para onde ir quando saírem do hospital ou cuja família se encontra totalmente desagregada, enfrentando o desemprego, às vezes, abalada por brigas e dissensões ou intensamente ameaçada pelo comportamento desajustado de um de seus membros. O médico assistente pode perceber essa situação como algo fora de sua esfera de responsabilidade, esperando que o psiquiatra, de alguma forma, possa ajudar.

O que, para alguns, pode parecer uma situação sem saída, pode ser, para um assistente social, um problema que faz parte de sua rotina, passível de algum encaminhamento. Esse profissional poderá, por exemplo, entrar em contato com organizações sociais de apoio a pacientes, como órgãos do poder público.

Diante de tantas situações-limite que o interconsultor tem de enfrentar, vale lembrar a observação de Ferrari e colaboradores:⁵

O interconsultor não deve se esquecer das características especiais do ambiente em que se move, no qual existe sempre o perigo latente de se ver arrastado para situações de conflito, identificando-se com aspectos ou partes destas, seja aliando-se ao médico, contra o paciente, ou ao paciente, contra o médico, perdendo de vista o marco habitual que deve presidir seu trabalho. Portanto, é imperioso que o interconsultor preserve seu próprio *setting* de trabalho. Este *setting* não tem os aspectos formais estáveis que medeiam o intercâmbio, como o espaço geográfico determinado, o estabelecimento de horários, etc. Em consequência, o interconsultor necessita respaldar-se em seu próprio *setting* interno, isto é, na possibilidade de manter uma distância emocional mínima e ótima para operar com seu próprio esquema referencial.⁵

De fato, o interconsultor expõe-se a situações extremamente graves e perturbadoras, fora de ambientes psicoterapêuticos habituais, o que imprime uma sobrecarga emocional adicional a seu trabalho. Por isso, é desejável que o interconsultor submeta-se a psicoterapia. Também por isso,

há necessidade de a equipe de interconsulta fazer reuniões rotineiras, nas quais reações individuais possam ser compartilhadas e compreendidas.

Entre as principais motivações de um psiquiatra para trabalhar em interconsulta, encontram-se: vocação (61%); renovação de conhecimentos (51%); expansão do relacionamento profissional (43%); acadêmica/científica (36%); e forma de contrapor o isolamento profissional do consultório (33%). Esses foram os resultados obtidos em uma enquête feita com psiquiatras formados em duas instituições de ensino nacionais.⁷

As dificuldades mais citadas pelos que trabalhavam em interconsulta foram: irregularidade das chamadas (33%); desvalorização do psiquiatra pelos outros médicos (33%); remuneração insuficiente (25%); ambiente de trabalho adverso (20%); e desvalorização das atividades por outros psiquiatras (20%). A falta de tempo e os honorários insuficientes foram as razões mais citadas entre os entrevistados que, já tendo trabalhado em interconsulta, haviam desistido de fazê-lo.⁷

O interconsultor é um profissional que se sente motivado por sua vocação, bem como pela possibilidade de renovar conhecimentos e de expandir seu relacionamento profissional. Em pouco mais da metade das vezes, como apuramos, realiza-se um trabalho solitário, de 7 horas semanais em média, sem horário fixo, que responde ao atendimento de interconsultas, em geral, sem estar ligado a uma equipe assistencial ou a uma equipe de interconsulta. Não ter vinculação com uma equipe de interconsulta e fazer consultoria esporadicamente significam entrar em campo só para atender casos pontuais, sem o compromisso com a manutenção do serviço. Isso torna crítica a qualidade de seu trabalho, bem como seu senso de valorização profissional.

O interconsultor tem a percepção de que seu trabalho não é adequadamente valorizado por outros especialistas (1/3 das respostas), nem mesmo por colegas da mesma especialidade (1/5 das respostas). Outro ponto crítico refere-se à remuneração: não está prevista pelo Sistema Único de Saúde (SUS), nem por vários convênios, portanto, a interconsulta é desconsiderada. Essa situação nos obriga a oferecer “amostras grátis” de nosso trabalho, na aposta de que sejam percebidas as vantagens de sua utilização.⁷

Entretanto, o interconsultor, apesar de todas as dificuldades, é um entusiasta. É capaz de se sentir gratificado pelas experiências enriquecedoras por que passa junto a pacientes, colegas médicos e outros membros da equipe assistencial. As situações clínicas de que participa levam ao amadurecimento pessoal, a vínculos de amizade e ao desenvolvimento de atividades dinâmicas. Há pacientes que melhoram muito após sua intervenção e também situações nas quais o psiquiatra, como catalisador de um grupo de profissionais, obtém resultados que não poderiam ser alcançados em seu trabalho regular com pacientes que normalmente vê em consultórios e hospitais psiquiátricos.

A DECISÃO DE ENCAMINHAR AO PSQUIATRA

Idade, gênero, personalidade, especialidade, características do treinamento e da prática profissional são alguns dos fatores concernentes à pessoa do médico que podem interferir no reconhecimento de transtornos psiquiátricos e na decisão de encaminhar um paciente ao psiquiatra. Cada médico teria um “limiar de encaminhamento” diferente, ou seja, um nível de tolerância a partir do qual o estímulo da situação clínica desencadearia o encaminhamento. Esse limiar é influenciado pelo tipo de formação recebida pelo médico, sua experiência, sua tolerância à incerteza, seu senso de autonomia e seu interesse por aspectos psicológicos da prática médica.^{6,8}

A frequência e o tipo de encaminhamentos parecem diferir entre as diversas especialidades médicas. Clínicos e cirurgiões geralmente são tomados como paradigmas; os primeiros dispendo-se mais a tratar transtornos psiquiátricos, como depressão, ansiedade e transtornos funcionais, valorizam e solicitam mais interconsultas.⁹⁻¹¹ Cirurgiões, quando pesquisados, estimam menor frequência de transtornos mentais entre seus pacientes. Distintamente dos clínicos, por exemplo, tendem a não considerar casos de agitação psicomotora como emergência psiquiátrica. Por sua vez, situações em que o paciente não adere às regras hospitalares são vistas como emergenciais.⁹

Outras resistências ao encaminhamento incluem a descrença dos médicos em relação aos tratamentos psiquiátricos e o receio de que a proposta de consulta com o psiquiatra provoque complicações, quer ofendendo o paciente e familiares, quer dificultando, posteriormente, a relação médico-paciente.¹²⁻¹⁵

Os médicos, em geral, não têm uma representação única da imagem do psiquiatra, senão múltiplas representações fragmentárias que correspondem a facetas da psiquiatria, relativas a sua prática, sua eficácia, suas modalidades de comunicação, terapêutica e instituições. Avaliadas por diversos métodos, as imagens que os médicos têm do psiquiatra variam, compreensivelmente, em cada sujeito, cada região e tipo de serviço. É difícil determinar de que psiquiatria falam, em uma mistura de imagens do antigo e do novo, mesclando críticas e elogios.¹⁶

De qualquer maneira, o que os médicos expressam pode ser tomado como um referencial na tentativa de diminuir a distância entre o que se espera e o que efetivamente pode ser realizado pelo psiquiatra no hospital geral. Em uma citação bem-humorada, Don Lipsitt, um psiquiatra norte-americano, procura defender seus colegas psiquiatras de algumas críticas que lhes são dirigidas. Ao mesmo tempo, dá alguns conselhos valiosos:

[O interconsultor] deve, frequentemente, esperar pacientemente que os outros reconheçam problemas que ele já percebeu antes que pudesse oferecer assistência; ele deve ser capaz de tolerar abuso verbal e rejeição de um paciente que, de início, não havia requisitado seus serviços, uma vez que ele é considerado um agente do médico, e não do paciente; ele deve saber como admitir com delicadeza que ele comumente tem pouco ou nada a oferecer; ele deve evitar a tentação narcisista de ter um desempenho mágico, ou de que ele sabe tratar melhor o paciente do que o médico assistente; ele deve ter suficiente flexibilidade para alterar sua postura de acordo com as necessidades da situação, sem comprometer suas habilidades ou contribuições, e deve prontamente reconhecer que, às vezes, algumas das piores coisas que seus colegas não psiquiatras dizem a seu respeito podem ser verdadeiras.¹⁷

A revisão dos estudos que se ocuparam dos fatores que influenciam o encaminhamento ao psiquiatra sugere que há uma combinação de diversas condições pessoais, clínicas e sociais que exercem ações variáveis em cada situação de encontro entre médicos e pacientes. A riqueza desse dinamismo desaconselha conclusões reducionistas e abre espaço para uma visão compreensiva dos encaminhamentos ao psiquiatra, assunto que é abordado no Capítulo 7.

RELAÇÃO MÉDICO-ESPECIALISTA

Muitos pedidos de interconsulta necessitam ser elaborados, e o médico tem de superar a crise de confiança que se instala na relação com o paciente ou consigo próprio. Terá, ainda, de superar o receio da entrada de outro profissional para analisar a relação mantida com o paciente. O pedido de interconsulta pode ser postergado até que se atinja o limite de tolerância do médico. Quando este finalmente opta pelo encaminhamento, pode estar tão angustiado que a presença do psiquiatra se reveste de um caráter de urgência; urgência que é mais do médico do que do paciente.

O pedido de interconsulta surge como um compromisso entre o impulso inconsciente de rejeitar a ajuda de outro profissional e a necessidade consciente de cumprir a responsabilidade profissional em relação ao paciente. A relação médico-especialista também traz essa ambivalência. Balint¹⁸ localiza no respeito ambivalente ao especialista a perpetuação da relação mestre-aluno. O médico olha o especialista como um profissional mais capaz, sobre cujo procedimento não tem controle, ao mesmo tempo que sente por ele respeito e credibilidade, que são herança trazida de seus sentimentos em relação aos antigos mestres da graduação.

Seguindo a mesma linha de raciocínio, podemos afirmar que muito do que os médicos fazem por seus pacientes reflete a intenção de manter e sustentar, em algum lugar dentro de si, suas relações com seus próprios professores, ídolos e *alma mater*. Ao especialista seriam remetidas as mesmas confiança e esperança depositadas nos pais durante a infância e no médico pessoal em situações de doença.¹⁹

Alguns depoimentos, transcritos a seguir, de médicos participantes de um grupo de reflexão ilustram o que afirmamos e revelam dois grupos de problemas:

1. comumente, o médico assistente tem dificuldade para encaminhar ao psiquiatra, não sabendo como explicar essa necessidade ao paciente;
2. algumas dificuldades sentidas pelos médicos podem ser projetadas no psiquiatra.²⁰

Ainda assim, devemos supor que várias reclamações por eles feitas são pertinentes e complicam a relação médico-especialista:

Minha maior dificuldade é encontrar o psiquiatra para interconsulta. A seguir, confiar nele. A maioria não entende o que está acontecendo, passa um diazepam e desaparece [...].

Sensação de desigualdade, diante de uma pessoa [o psiquiatra] que entende melhor esse mundo desconhecido [...].

Alguns psiquiatras querem nos analisar e nem sempre emitem sua opinião quando a desejamos.

É difícil recomendar um psiquiatra. Alguns podem até piorar a cabeça do indivíduo [...].

Fazer o psiquiatra entender que encaminho o paciente não porque seja incapaz de resolver o problema clínico, mas porque me sinto impotente para tratar o doente, e não a doença. O psiquiatra muitas vezes vem com desdém, ou quer pegar o caso para ele [...].

O psiquiatra chamado para a interconsulta pode ser aguardado com muita expectativa e idealização de que ele dê uma solução rápida, às vezes mágica, por meio de poderes de penetrar na mente e de persuadir. Contudo, a entrada desse profissional na relação médico-paciente pode acentuar fantasias paranoides de cerceamento de um poder reparatório que, ansiosamente, o médico gostaria de reter para si.²¹ Assim, o especialista pode ser muito idealizado em um momento e, a seguir, ter de enfrentar hostilidade, ciúme e desconfiança. Quando tiver de acompanhar o paciente, será convidado a se integrar ao atendimento prestado pela equipe assistencial ou, então, a se manter distante, participando da dissociação feita em relação aos aspectos emocionais do paciente.

Os médicos valem-se do encaminhamento de diferentes maneiras, por vários motivos. Do especialista, esperam-se coisas diferentes. Isso influi na escolha de para quem determinado paciente será encaminhado. Algumas vezes, o profissional escolhido é uma pessoa rígida, outras vezes, gentil. Essas considerações de parte do médico podem ser realistas e conscientes, tendo em vista características da personalidade do paciente. No entanto, isso vai além: fatores inconscientes podem determinar a procura de um especialista idealizado ou de um denegrido, ou mesmo, para determinado problema, um profissional que seja um enigma.

Em outras palavras, a relação com o paciente, bem como a decisão de para quem encaminhar, são influenciadas por necessidades emocionais do médico, e essas necessidades também modulam o relacionamento médico-especialista.

Quanto mais seguro emocionalmente for o médico assistente, mais fácil será para ele pedir ajuda de um psiquiatra, uma ajuda que leve mais em consideração as necessidades de seus pacientes do que conflitos seus ou sua relação com o paciente. Esse médico encontrará menos dificuldade de comunicar ao paciente e seus familiares sua decisão de contar com a ajuda de um psiquiatra. Enfim, a interconsulta psiquiátrica será tratada como outras interconsultas, de outras especialidades, e não será revestida de um caráter excepcional.

Entretanto, devemos lembrar que algumas resistências de colegas médicos em relação ao psiquiatra ou à psiquiatria podem ter origem nas defesas que eles próprios mantêm contra a invasão de sentimentos e emoções que poderiam interferir negativamente em seu trabalho. Compreender essas circunstâncias pode diminuir tais resistências e facilitar a cooperação entre o médico assistente e o psiquiatra interconsultor. Elas também diminuem quando demonstramos a nossos colegas que primeiro somos médicos, depois psiquiatras.

Entre o médico capaz de proceder a encaminhamentos de forma adequada e o médico frontalmente resistente ao psiquiatra, encontram-se vários tipos de relações mantidas com o psiquiatra, descritas por Krakowski¹⁷ e resumidas a seguir:

- **O médico demasiadamente ávido** geralmente atua com exagero de zelo, verificado pela diversidade de exames solicitados e o número de especialistas consultados. Esse médico que parece tão atento e preocupado com a problemática – possivelmente mais dele do que do paciente – pode se esquecer, por exemplo, de dizer a este que chamou um psiquiatra para avaliá-lo. De qualquer forma, o médico demasiadamente “ávido” pela interconsulta psiquiátrica necessita de pronta resposta do psiquiatra, porque suas inquietudes, relacionadas ao paciente ou não, são urgentes e merecem toda consideração.

- O **médico “toma lá dá cá”** só encaminha um paciente ao especialista que lhe encaminhou outro paciente, em um gesto de agradecimento. A motivação para o encaminhamento pode ser mais pela manutenção do coleguismo do que pelas necessidades do paciente, que terá de ser “persuadido” a consultar o psiquiatra.
- O **médico esquecido** não avisa o paciente sobre a interconsulta, não lembra de redigir o pedido de interconsulta no impresso próprio e se esquece de conversar com o interconsultor sobre o caso. Em geral, deixa essas tarefas para o enfermeiro ou um subalterno seu. A interconsulta geralmente é solicitada às vésperas da alta do paciente. E é desnecessário dizer que esse médico vai se esquecer de ler as anotações do psiquiatra.
- O **médico apologético** excede-se nas justificativas prestadas ao paciente e a familiares, a fim de disfarçar seu embaraço ao ter de chamar um psiquiatra. Ele poderá referir-se ao psiquiatra como “neurologista” ou “médico especialista nesses problemas”, enaltecendo sua amizade e sua confiança inabalável no profissional. Ele acrescentará que, afinal, não custa nada bater um papinho, que “mal não vai fazer”, e inclusive que “não sei quem um dia já precisou e foi muito bom”.
- O **médico expert**, na realidade, já sabe de tudo. Apenas gosta de ouvir um especialista que confirme suas acertadas opiniões. Ele não tem dúvidas, mas quer estar “perfeitamente seguro”. Se ouvir do interconsultor uma opinião diferente da sua, poderá dizer que havia mesmo pensado nessa possibilidade, disfarçando seu desagrado, para, em seguida, pedir uma opinião “independente” de outro psiquiatra. Ele poderá evitar novos encaminhamentos ao primeiro psiquiatra, passando a prestigiar os novos colegas especialistas “que estão despontando” (e são mais condescendentes).
- O **médico punidor** vale-se do encaminhamento para punir seus pacientes quando a relação médico-paciente está abalada. Isso pode ocorrer, por exemplo, quando o paciente o questiona por que não tem melhorado. Sua raiva e frustração são “encaminhadas” a outro profissional, às vezes sem que o paciente seja preparado de forma adequada para isso, em uma situação que pune tanto o paciente quanto o interconsultor.

O Quadro 5.1 destaca alguns dos “abusos” que, mais frequentemente, médicos assistentes e interconsultores cometem na interconsulta psiquiátrica.

QUADRO 5.1

Abusos em interconsulta psiquiátrica

Abusos do médico assistente:

■ **Orgânico ou psíquico?**

Anamnese bem feita e exames cuidadosos costumam esclarecer isso. Múltiplos fatores etiológicos são geralmente responsáveis.

■ **Distância sociocultural**

A capacidade do médico de detectar e encaminhar problemas emocionais diminui, na medida em que não consegue superar a distância sociocultural entre ele e o paciente.

■ **Ignorar o papel da enfermeira**

Por estar mais próxima do paciente, a enfermeira deve ser encorajada a relatar ao médico as dificuldades emocionais ou comportamentais que ela observa.

■ **Não se dar conta da negação do paciente**

Se um paciente nega seus sentimentos e sua necessidade de ajuda, provavelmente ele não será detectado como alguém que necessita ser avaliado pela interconsulta psiquiátrica.

■ **Não encaminhar o paciente terminal**

Há pelo menos três circunstâncias em que o psiquiatra deveria ser chamado: dificuldade de manejo, transtornos psiquiátricos (*delirium*, depressão, ansiedade), quando o paciente está solitário.

■ **História incompleta**

O médico, por dificuldades pessoais ou por descaso, “deixa” para o psiquiatra a obtenção de dados essenciais ao entendimento do caso.

Abusos do psiquiatra:

■ **Demora**

Isso aumenta a ansiedade do médico assistente e impõe riscos ao paciente. Se muito atarefado, comunicar-se rapidamente para determinar prioridade.

■ **Não revisar as anotações do prontuário**

Revisar o prontuário educa o psiquiatra, apura o diagnóstico e oferece uma base de informação comum em sua interação com o médico assistente.

■ **Registro inadequado no prontuário**

O registro deveria responder questões específicas do médico assistente e ser assim estruturado: dados factuais que corroboram o diagnóstico, formulação compreensiva da situação clínica, planejamento terapêutico (incluindo situações de intercorrência e de alta hospitalar).

■ **Assumir o controle do caso**

Na maioria das vezes, o responsável primário pelo paciente continuará sendo o médico assistente. Com ele, o interconsultor deve discutir seus planos, antes de informar pacientes e familiares.

Fonte: Com base em Schwab e Brown.²²

Tempo, caminhadas e conversas

Na interconsulta, é preciso tempo e boas caminhadas pelos corredores do hospital para conseguir encontrar o colega que pediu a interconsulta, entrar em contato com o serviço social, chegar até onde os familiares do paciente nos esperam, etc. Em um hospital universitário, a tarefa complica-se pela profusão de serviços, reuniões, seminários, rodízios e plantões em que as pessoas podem estar. Essa realidade, além de contribuir para a boa forma física do interconsultor, representa tempo e energia bem gastos. Ao interconsultor, cabe a “costura” de diferentes fontes de informação e de auxílio potencial para o paciente. Muitas vezes, somos facilitadores da comunicação ou catalisadores de uma mobilização empreendida para alterar o estado de coisas que bloqueiam o desenrolar adequado da tarefa assistencial.

Além disso, nesses deslocamentos pelos corredores do hospital, encontram-se colegas de outras especialidades, discutem-se casos, trocam-se ideias. O interconsultor recebe muitas informações e, com sua postura e seu interesse, também fornece informações. Ele transmite algo de si, desde sua técnica até traços de personalidade e de sua disposição para o trabalho. Essas informações são muito importantes para criar um espírito de confiança e de cooperação.

Na interconsulta, como se vê, não se gasta apenas a sola do sapato, também é preciso “gastar” conversa. É dessa forma que se estabelece a boa comunicação e que se fortalecem os vínculos. É por isso que se diz, com boa dose de razão, que, no âmbito do hospital geral, o interconsultor é o embaixador da psiquiatria.

A interconsulta é, também, uma importante estratégia pedagógica destinada a melhorar a qualificação profissional das equipes de saúde, aumentando sua capacidade de identificar e lidar com problemas de natureza psicossocial ou psiquiátrica, em uma população em que a prevalência de tais problemas é alta.

Este último é, no entanto, um ponto delicado – embora o desejemos, não há evidências de que a presença da psiquiatria nos hospitais torne os médicos mais sensíveis aos aspectos emocionais presentes na prática médica. Muitos têm enfatizado que o caminho para uma convergência entre médicos de outras especialidades e psiquiatras reside no cuidado dedicado ao doente, e não em um papel primariamente de “educador” da interconsulta. Compartilhamos dessa noção: a interconsulta ensina quando oferece a alunos e profissionais o modelo de identificação “faça como você está me vendo fazer”.

REFERÊNCIAS

1. Zaidhaft S. A saúde mental no hospital geral e seu impacto sobre a formação médica. Cadernos IPUB. 1967;6:71-84.
2. Demo P. Metodologia científica em ciências sociais. São Paulo: Atlas; 1980.
3. Sensky T. The general hospital psychiatrist: too many tasks and too few roles? Br J Psychiatry. 1986;148:151-8.
4. Jacintho ACA. A interconsulta psiquiátrica: dificuldades de um interconsultor [monografia]. Campinas: Departamento de Psicologia Médica e Psiquiatria, UNICAMP; 1988.
5. Ferrari H, Luchina N, Luchina IL. La interconsulta médico psicológica en el marco hospitalario. Buenos Aires: Nueva Vision; 1977.
6. Mendelson M, Meyer E. Countertransference problems of the liaison psychiatrist. Psychosom Med. 1961;23:115-22.
7. Botega NJ, Guilhermano LG, Michel R, Garcia Jr. C, Machado FG, Crestana F, et al. Consultoria psiquiátrica em hospital geral: inviável ou promissora? Rev Bras Psiquiatr. 2000;22(3):130-2.
8. Cummins RO, Jarman B, White PM. Do general practitioners have different referral thresholds? Br Med J (Clin Res Ed). 1981;282(6269):1037-9.
9. Fauman MA. Psychiatric components of medical and surgical practice: a survey of general hospital physicians. Am J Psychiatry. 1981;138(10): 1298-301.
10. Millan LR, Miguel Filho EC, Lima MGA, Fráguas Júnior R, Gimenès R. Psiquiatria no hospital geral: experiência de um ano. Revi Psiquiatri Clín. 1986;13(1-4):33-8.
11. Millan LR, De Marco OLN, Rossi E, Arruda PCV. O universo psicológico do futuro médico. São Paulo: Casa do Psicólogo; 1999.
12. Steinberg H, Torem M, Saravay SM. An analysis of physician resistance to psychiatric consultation. Arch Gen Psychiatry. 1980;37(9):1007-12.
13. Botega NJ. A palavra do médico e seus sentidos: um estudo qualitativo de alguns termos psiquiátricos utilizados na prática médica. Rev ABPAPAL. 1992;14(1):33-8.
14. Botega NJ, Silveira GM. General practitioners' attitudes towards depression - a study in primary care setting in Brazil. Int J Soc Psychiatry. 1996;42(3):230-7.
15. Meleiro, AMAS. O médico como paciente. São Paulo: Lemos; 1999.
16. Escande M. Le psychiatrie vu par l'omnipraticien. Confront Psychiatr. 1979;17:59-91.
17. Krakowski AJ. Psychiatric consultation in the general hospital: an exploration of resistances. Dis Nerv Syst. 1975;36(5):242-4.
18. Balint M. The doctor, his patient, and the illness. New York: Int. Universities; 1973.
19. Bourne S. Second opinion: a study of medical referrals in a seminar for general practitioners at the Tavistock Clinic, London. J R Coll Gen Pract. 1976;26(168):487-95.
20. Cassorla RMS. O psiquiatra na equipe médica: retratos e caricaturas. Cadernos IPUB. 1997;6:45-58.

21. Knobel M. La relación entre el médico y el psicoterapeuta em el tratamiento de la enfermedad somática. *Acta Psiquiatr Psicol Am Lat.* 1986;32:31-40.
22. Schwab JJ, Brown J. Uses and abuses of psychiatric consultation. *JAMA.* 1968;205(2):65-8.



Saúde mental dos profissionais da saúde

Luiz Antonio Nogueira-Martins

O tema do capítulo é desenvolvido destacando-se o papel do estresse ocupacional inerente à atividade assistencial em saúde. O exercício profissional da medicina é utilizado como modelo ilustrativo das outras profissões da área da saúde. Após a descrição de três modelos conceituais de estresse ocupacional, são apresentadas algumas características psicológicas, sociais e ocupacionais do exercício atual da medicina no Brasil. Desenvolvem-se, a seguir, de forma detalhada, aspectos relacionados à saúde mental, ao sofrimento psíquico e ao estresse psicológico na formação e no exercício profissional em medicina. Um elenco de medidas é proposto para o aprimoramento da atenção à saúde mental e à qualidade de vida de estudantes e profissionais.

Neste capítulo, será abordada a questão da saúde mental dos profissionais da saúde, considerando o exercício profissional da medicina como modelo ilustrativo das outras áreas.

Vale assinalar que, embora conservem características próprias de cada profissão, vários aspectos da atividade profissional em saúde são compartilhados por médicos, enfermeiros, assistentes sociais, terapeutas ocupacionais, psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos e farmacêuticos. No que diz respeito à saúde ocupacional, por exemplo, o sofrimento psíquico inerente ao trabalho no âmbito hospitalar tende a ser comum a todos esses profissionais.^{1,2}

Um exemplo dessa assertiva pode ser constatado em uma antiga pesquisa sobre o trabalho de enfermeiros, realizado em um hospital de Londres, a respeito dos efeitos do estresse associado à tarefa assistencial.³ Nesse estudo, foi observado alto nível de tensão, angústia e ansiedade entre os enfermeiros, com faltas e abandonos da tarefa, mudanças frequentes de emprego e alta frequência de pequenos problemas de saúde que requeriam alguns dias de ausência no trabalho.

A autora refere que a situação de trabalho suscita sentimentos muito fortes e contraditórios nos enfermeiros: piedade, compaixão e amor; culpa e ansiedade; ódio e ressentimento contra os pacientes que fazem emergir esses sentimentos fortes; e inveja do cuidado oferecido ao paciente. Observou também que os pacientes e seus familiares nutrem sentimentos complexos em relação ao hospital, que são expressos em particular e de forma mais direta aos enfermeiros e que, com frequência, os deixam confusos e angustiados. Por um lado, os pacientes e seus familiares demonstram apreço, gratidão, afeição, respeito e consideração, além de uma comovente crença de que o hospital funciona e solidariedade e preocupação para com os enfermeiros em seu difícil trabalho. Por outro lado, os pacientes se ressentem de sua dependência, tendem a aceitar de má vontade a disciplina imposta pelo tratamento e pela rotina hospitalar, invejam os enfermeiros por sua saúde e competência e são exigentes, possessivos e ciumentos.

Esse breve retrato psicodinâmico da tarefa profissional de enfermeiros com pacientes hospitalizados pode ser aplicado, em graus variados, ao conjunto dos profissionais que fazem parte da equipe de saúde, cuja composição tem mostrado crescente tendência a apresentar configurações multiprofissionais e multidisciplinares.

Vários estudos têm sido desenvolvidos em nosso meio abordando temas relacionados com o sofrimento psíquico e o estresse ocupacional vivenciado pelos membros de equipes de saúde que

trabalham em diferentes espaços assistenciais, como hospital geral,^{4,5} serviços de emergência,⁶ programa de saúde da família,⁷ serviços de oncologia^{8,9} e unidades de terapia intensiva.¹⁰⁻¹⁴ Profissionais da área de saúde mental também têm sido objeto de estudos sobre estresse ocupacional, *burnout*, qualidade de vida e satisfação profissional.¹⁵⁻¹⁷

O PERFIL DO MÉDICO BRASILEIRO

Em um excelente livro intitulado *Os médicos no Brasil: um retrato da realidade*, Machado¹⁸ publicou os resultados de uma das mais extensas e aprofundadas pesquisas sociológicas sobre a profissão médica e o exercício da medicina na atualidade. Dados extraídos dessa pesquisa e de estudos posteriores¹⁹⁻²³ apontam para as seguintes tendências na caracterização psicossociológica da população médica brasileira (estimada atualmente em 430 mil médicos em atividade):

- forte adesão ao projeto profissional (poucos médicos abandonam a profissão)
- vocação urbana (a maioria vive e trabalha em cidades médias ou grandes capitais)
- linhagem médica na família e afinidade profissional (famílias constituídas por muitos médicos e casamentos entre médicos)
- categoria de jovens (a maioria tem idade inferior a 45 anos)
- feminização da profissão (as mulheres representam quase metade da população médica atual)
- assalariamento da categoria e perda da atividade liberal e da autonomia profissional (uma minoria exerce atividade liberal exclusiva; a maioria dos médicos que trabalham em consultório particular atende a convênios de saúde)
- tendência ao crescimento da procura por especialidades cirúrgicas (oftalmologia, otorrinolaringologia, ortopedia, urologia) e de métodos diagnósticos (diagnóstico por imagem)
- em relação às perspectivas da profissão, predominam sentimentos de incerteza e pessimismo em relação ao futuro

O exercício atual da medicina

Dados internacionais têm mostrado a presença de expressivos graus de insatisfação entre os médicos com relação ao exercício profissional.^{24,25} Além disso, um estudo nacional revelou que a insatisfação profissional está associada aos seguintes fatores: excesso de trabalho, múltiplos empregos, baixa remuneração, más condições de trabalho, alta responsabilidade profissional, dificuldades na relação com os pacientes, cobrança da população e perda da autonomia. Esse mesmo estudo destaca que as relações de trabalho, o tempo dedicado à atividade profissional, as formas de remuneração e as questões éticas têm uma influência significativa na saúde do médico. Adverte, ainda, que o médico está entre as categorias que menos valorizam esses fatores de risco no trabalho.¹⁸

Outros estudos indicam, também, que as transformações na organização do trabalho do médico brasileiro têm tornado cada vez mais estressante e penoso o exercício profissional e contribuído para uma piora na relação com os usuários.¹⁹⁻²³ Uma pesquisa realizada pelo Conselho Federal de Medicina¹⁹ mostrou que, embora não haja desemprego na medicina, o perfil de atuação do médico no Brasil é, cada vez mais, de um profissional com atividades múltiplas.

Um conjunto de fatores tem contribuído para que o exercício atual da medicina tenha se tornado cada vez mais difícil no Brasil.^{20,26} A crescente presença das empresas compradoras de serviços médicos (que levaram à perda do caráter liberal da prática profissional), a desordenada

criação de novas escolas médicas (com o consequente crescimento do número de profissionais e o aumento da competição entre os médicos), o acelerado desenvolvimento de novos recursos diagnósticos e terapêuticos (que leva à necessidade constante de atualização) e a promulgação de novas normas e leis, como o Código de Defesa do Consumidor (com o consequente aumento do número de denúncias e queixas tanto na esfera judicial como no âmbito ético profissional), são fatores que pressionam os profissionais e têm produzido profundas transformações na profissão médica.

Essas pressões e mudanças levaram a perda da autonomia do profissional, perda de remuneração (que conduz ao *multiemprego*), aumento da competição com mudanças no comportamento ético na disputa profissional (o império do “vale tudo” e do “salve-se quem puder”), maiores dificuldades no relacionamento com os pacientes (em decorrência da maior cobrança social), aumento do risco profissional (processos éticos e judiciais), insatisfação com a profissão (perda ou diminuição da autoestima) e, conseqüentemente, mais riscos para a saúde física e mental.

Estresse ocupacional e saúde do médico: modelos conceituais

No campo da relação entre saúde e trabalho, três modelos conceituais merecem destaque: **estresse-adaptação**, *burnout* e **demanda-controle**.

O modelo conceitual do estresse apoia-se em uma concepção interacional que compreende o binômio **estresse-adaptação**. Em sua origem, o termo *estresse*, que veio da física, refere-se ao grau de deformidade que uma estrutura sofre quando é submetida a uma sobrecarga. O termo foi introduzido na medicina para nomear o conjunto de reações que um organismo desenvolve ao ser submetido a uma situação que exige um esforço adaptativo. Assim, o conceito de *estresse* está intimamente ligado à noção de adaptação. Uma definição operativa de estresse pode ser assim formulada: trata-se da resposta do organismo (corpo e mente) às pressões internas (desejos, ambições, expectativas, conflitos) e externas (pressões vinculadas ao exercício profissional e às condições de vida).

Ainda que os fatores que produzem a resposta adaptativa ao estresse sejam inerentes à vida, na atualidade, os estímulos estressantes oriundos do mundo do trabalho vêm adquirindo um papel extremamente importante. Do processo de avaliação (percepção, reconhecimento e identificação) dos fatores estressores ou estressantes, participam as variáveis individuais (características de personalidade, estilo de vida, experiências anteriores), que definem as chamadas estratégias de enfrentamento (*coping*), que são as formas habituais utilizadas pelos indivíduos para lidar com as situações estressantes. Outro conceito, também oriundo da física, denominado *resiliência*, refere-se à propriedade e à capacidade do organismo de suportar e lidar de forma satisfatória com as cargas e sobrecargas da vida. Esse conceito tem sido evocado para compreender por que alguns indivíduos conseguem se desenvolver em condições bastante desfavoráveis, enquanto outros não se adaptam e/ou adoecem.

Outro importante modelo conceitual é o de *burnout*.²⁷⁻³⁰ Descrito, a princípio, em profissionais da saúde que trabalhavam em instituições de assistência a pacientes usuários de drogas, *burnout*

refere-se ao estado físico e emocional que tem sido observado em alguns profissionais da saúde que se mostram, paulatinamente, queixosos, decepcionados e desiludidos com sua atividade profissional, caracterizando um quadro de disfunção profissional. O termo *burnout* designa o que deixou de funcionar por esgotamento de energia, indicando o estado de colapso decorrente do uso de toda a energia disponível. Uma imagem que tem sido utilizada para descrever essa síndrome é a da vela que ilumina e se consome. Há uma tendência a se considerar que o quadro tem como uma de suas características principais um estado de fadiga, frustração e desilusão derivado da devoção a uma causa, um modo de vida ou uma relação profissional que não produz a recompensa desejada.

A síndrome de *burnout*, ou síndrome do esgotamento profissional, tem sido estudada nas mais variadas profissões e ocupações. Profissionais de segurança pública e privada, operadores de bolsa de valores, motoristas de ônibus urbanos, controladores de voo, operadores de *telemarketing*, professores de ensino fundamental, enfermeiros e médicos de serviços de emergência e unidades de terapia intensiva têm sido considerados propensos a desenvolver a síndrome.³⁰

O profissional que padece de *burnout* costuma ter pouca energia para as diferentes solicitações de seu trabalho, desenvolve uma espécie de frieza e indiferença para com as necessidades dos usuários e dos colegas de trabalho, sente-se decepcionado e frustrado profissionalmente com comprometimento da autoestima e tende a reagir com ceticismo diante de sugestões e tentativas de ajuda.^{30,31}

Maslach e colaboradores³² destacam que, no âmbito da assistência à saúde, o *burnout* pode estar associado a dificuldades adaptativas que o profissional desenvolve ao ter que lidar com o estresse crônico relacionado à prestação de serviços à saúde, cuja tarefa, habitualmente, envolve uma atenção intensa e prolongada a pessoas que estão em situação de necessidade ou dependência.

A síndrome de *burnout* abrange três dimensões: exaustão emocional, despersonalização/desumanização e comprometimento do exercício e da realização profissional. É composta por sintomas somáticos, psicológicos e comportamentais (Quadro 6.1).

QUADRO 6.1

Síndrome de *burnout* (esgotamento profissional)

Sintomas somáticos	Fadiga, cefaleia, distúrbios gastrintestinais, alterações do sono, dores musculares
Sintomas psicológicos	Exaustão emocional, falta de concentração, humor depressivo, ansiedade, rigidez, negativismo, ceticismo, desinteresse, baixa autoestima
Sintomas comportamentais	Absenteísmo, erros profissionais, irritabilidade no relacionamento com os pacientes e colegas de trabalho, realização de consultas rápidas e tendência a colocar rótulos depreciativos nos pacientes e familiares

Um terceiro modelo conceitual que merece ser destacado, tanto por sua importância como elemento contributivo para o gerenciamento da organização do trabalho em saúde quanto pelo caráter dinâmico e interacional de sua concepção, é o modelo **demanda-controle**.³³ Nesse modelo, a demanda psicológica do trabalho do profissional é relacionada ao grau de autonomia e

controle que ele tem sobre sua atividade. O Quadro 6.2 apresenta a categorização das atividades laborais segundo o modelo demanda-controle.

QUADRO 6.2

Categorização das atividades laborais segundo o modelo demanda-controle

Categoria	Características	Exemplo
Alta exigência	Alta demanda psicológica e baixo controle da atividade	Trabalho em serviços públicos de emergência
Trabalho ativo	Alta demanda psicológica e alto controle da atividade	Atividade de direção em instituições de saúde
Trabalho passivo	Baixa demanda psicológica e baixo controle da atividade	Trabalho burocrático repetitivo com pouca responsabilidade
Baixa exigência	Baixa demanda psicológica e alto controle da atividade	Atividade com poucas solicitações e grande autonomia

Uma das vantagens desse modelo é que ele permite caracterizar e classificar atividades profissionais que apresentam maior grau de insalubridade psicológica e de risco de desenvolvimento de problemas de saúde. As categorias mais suscetíveis ao estresse ocupacional são alta exigência e trabalho passivo.

A SAÚDE DO MÉDICO

A saúde dos médicos tem sido objeto de preocupação de associações profissionais e órgãos reguladores do exercício profissional em diversos países.^{22,34,35} Os dados disponíveis mostram alguns aspectos positivos e outros preocupantes. Exemplos disso são certos hábitos nocivos à saúde, como o fumar e o sedentarismo, que estão em declínio, o que tem contribuído para uma diminuição na morbimortalidade devido a doenças associadas a esses comportamentos.

No entanto, há dados inquietantes. Certos comportamentos relativos ao cuidado com a própria saúde apontam para a existência de uma minimização dos riscos, em que concorrem diversos tipos de medo, como medo do diagnóstico, do tratamento e da perda da autoestima. Clever³⁶ cita algumas características do comportamento de muitos médicos que são de crucial importância para compreender vários aspectos relacionados aos mecanismos utilizados por esses profissionais em relação aos cuidados com a saúde:

[...] muitos médicos não têm seu próprio médico. [...]. O autotratamento, consultas de corredor e demoras devido ao constrangimento relativo à cortesia profissional podem impedir o diagnóstico e o tratamento. [...] Uma extensão patológica da negação é a “síndrome da invulnerabilidade médica”, que se caracteriza pela convicção de que os problemas pessoais e familiares, as complicações e as doenças que afetam outras pessoas não podem afetar o médico ou não irão fazê-lo.³⁶

Além disso, estudos sobre atitudes em relação ao adoecer têm mostrado que médicos, quando comparados a outros profissionais, tendem a faltar menos ao trabalho devido a problemas de saúde. Esse fenômeno não ocorre porque o médico é mais resistente às doenças, mas porque ele se mostra menos propenso a revelar seus males.

Outro fator de extrema relevância, diretamente associado ao tema do descuido com a própria saúde, é a qualidade da assistência que os médicos recebem quando estão doentes. Há vários indícios de que os médicos não são bem atendidos quando necessitam de cuidados médicos, o que reforça a tendência a não procurar ajuda.^{37,38}

Essa má qualidade da assistência prestada ao médico doente é um problema particularmente preocupante. É provável que um médico que tenha, por exemplo, um problema de dependência química o oculte por medo de ser punido e impedido de trabalhar, o que o leva a postergar ainda mais a busca de ajuda profissional. Além disso, receia que, se o fizer, poderá ser objeto de atitudes preconceituosas e provavelmente será mais mal assistido do que qualquer outro usuário de substâncias psicoativas. O mesmo ocorre em relação a outros problemas da área da saúde mental, campo ainda carregado de preconceitos no meio médico. Sabe-se hoje que o medo associado à desinformação desempenha importante papel na gênese e na manutenção desses comportamentos preconceituosos.

A SAÚDE MENTAL DO MÉDICO

Características psicológicas da tarefa médica

Há inúmeras gratificações psicológicas inerentes à profissão médica. Aliviar a dor e o sofrimento, curar doenças, salvar vidas, sentir-se competente, ensinar, aconselhar, educar, prevenir doenças, receber reconhecimento e gratidão são algumas das características psicológicas da tarefa médica que fazem da medicina uma profissão ainda muito atraente e gratificante.

A medicina permanece, a despeito da crise que atravessa esse meio, uma profissão que oferece várias possibilidades de realização material, intelectual e emocional. É uma área fascinante, de capital importância para a sociedade e, como tal, uma carreira desejada e idealizada pelos jovens. O grau de idealização pode, no entanto, gerar altas expectativas, que, quando não correspondidas, tendem a produzir decepções e frustrações significativas, com repercussões na saúde dos estudantes, residentes e médicos.

Um importante ponto que merece ser destacado ao estudarmos a tarefa médica é o caráter altamente ansiogênico do exercício profissional. No trabalho clínico, há, como regra, com pequenas variações, a exposição a poderosas radiações psicológicas emanadas do contato íntimo com o adoecer. Cumpre enfatizar esse aspecto, já que, em especial no âmbito assistencial dos serviços de emergência, ocorrem situações tão dramáticas que talvez não ocorram em nenhum outro campo da atividade humana em tempos de paz. Esse caráter estressante inerente à tarefa médica tem-se amplificado de forma significativa devido ao volume de pacientes e às condições precárias de trabalho vigentes, sobretudo nos serviços de emergência da rede pública, o que tem gerado situações de franca hostilidade por parte de pacientes e familiares.

Algumas das características inerentes à tarefa médica definem, isoladas ou em conjunto, um ambiente profissional cujo colorido básico são os intensos estímulos emocionais que acompanham o adoecer e os cuidados com os pacientes:³⁹⁻⁴¹

- ter contato íntimo e frequente com a dor e o sofrimento
- lidar com a intimidade corporal e emocional
- atender pacientes terminais
- lidar com pacientes de difícil manejo: queixosos, rebeldes, que não aderem ao tratamento, hostis, reivindicadores, autodestrutivos, cronicamente deprimidos
- lidar com as incertezas e limitações do conhecimento médico e do sistema assistencial que se contrapõem às demandas e expectativas dos pacientes e familiares, que desejam certezas e garantias

Essa insalubridade psicológica permeia a graduação, e, na residência médica, o estresse atinge o seu ápice. O período de transição de aluno para médico, a responsabilidade profissional, o isolamento social, a fadiga, a privação do sono, a sobrecarga de trabalho, o medo de cometer erros e outros fatores inerentes ao treinamento estão associados a diversas expressões psicológicas, psicopatológicas e comportamentais. Estas incluem estados depressivos com ideação suicida, consumo excessivo de álcool e drogas psicoativas, raiva crônica e o desenvolvimento de um amargo ceticismo e um irônico humor negro.^{40,41}

Em um estudo prospectivo realizado com residentes de 12 programas de Residência Médica, os resultados mostraram que as principais dificuldades encontradas pelos residentes na tarefa assistencial foram:⁴¹

- quantidade de pacientes
- comunicação com pacientes de baixo nível socioeconômico e cultural
- pacientes hostis e/ou reivindicadores
- pacientes terminais
- pacientes com alteração de comportamento
- comunicações dolorosas (comunicar ao paciente e/ou à família situações graves ou de morte)
- dilemas éticos
- medo de contrair infecções durante a realização de procedimentos médicos

Nesse estudo, as principais fontes de estresse identificadas pelos residentes foram:

- medo de cometer erros
- fadiga ou cansaço
- falta de orientação
- estar constantemente sob pressão
- plantão noturno
- excessivo controle por parte dos supervisores
- lidar com as exigências internas (“ser um médico que não falha”)
- falta de tempo para lazer, família, amigos, necessidades pessoais

Morbidade psicológica e psiquiátrica

Uma alta prevalência de suicídio e ideação suicida, depressão, estresse, *burnout*, uso de substâncias psicoativas (medicamentos, álcool e outras drogas), crises conjugais e disfunções profissionais em médicos,^{34,42-45} assim como altos índices de estresse, ansiedade e depressão em estudantes de medicina,^{46,47} residentes^{40,41} e pós-graduandos,⁴⁸ têm sido descritos na literatura.

Esses temas costumam ser abordados no cotidiano da vida profissional. Em encontros informais, médicos costumam recordar-se de um ou dois colegas de turma que morreram por suicídio ou que ficaram incapacitados para o exercício profissional devido a transtornos psiquiátricos, associados ou não ao uso de substâncias psicoativas. Vale assinalar que a preocupação com o suicídio em médicos é antiga e permanece atual na literatura.⁴³⁻⁴⁵ Em 1858, na Inglaterra, essa questão já chamava a atenção dos médicos. Em 1903, um editorial do JAMA discutiu a magnitude do problema; cem anos depois, a mesma revista publicou um artigo que indicava a necessidade e a importância de ampliar a divulgação desse tema entre os médicos.⁴³

Estima-se que 10 a 12% dos médicos têm ou virão a ter problemas de natureza psicológica e psiquiátrica. Alguns grupos de médicos são considerados de maior risco para o desenvolvimento de transtornos emocionais e problemas profissionais. Os residentes, em especial os de primeiro ano, são mais suscetíveis ao desenvolvimento de estresse e depressão, apresentando taxas de

prevalência maiores que a população em geral e outros grupos profissionais.^{40,41} Médicos com dependência química também representam um grupo que merece especial atenção devido aos riscos associados ao exercício profissional. Um estudo realizado com médicos em tratamento ambulatorial por uso de drogas mostrou que 66% já tinham sido internados por abuso de álcool e/ou drogas; 33% apresentavam comorbidade psiquiátrica; 33% ficaram desempregados; 68% tiveram problemas no casamento; 42% tiveram acidentes automobilísticos; 19% tiveram problemas jurídicos; 66% apresentaram prejuízo na prática da profissão; e 8,5% tiveram problemas junto aos Conselhos Regionais de Medicina (CRM).⁴⁹ Outro estudo, realizado com 192 usuários de um serviço específico para atendimento a médicos – rede de apoio a médicos dependentes de álcool e drogas⁵⁰ –, revelou os seguintes dados: 158 homens, a maioria casada, com idade média de 43 anos, apresentaram um intervalo de tempo médio entre a identificação do problema e a busca de tratamento de 7,5 anos. Agravando o problema, 22% estavam desempregados, 31% já tinham passado por internação psiquiátrica e 72% relataram que se automedicavam. Os autores salientam que a criação de serviços específicos de atenção à saúde mental dos médicos pode ter um efeito catalisador nas mudanças culturais quanto à procura de ajuda, favorecendo a detecção precoce e o tratamento.

A vulnerabilidade psicológica do médico

A natureza estressante do exercício profissional e da formação médica e as características psicodinâmicas que conduzem os indivíduos para a carreira médica têm sido habitualmente apontadas como fatores responsáveis ou desencadeantes de problemas emocionais em médicos. Há dados de países desenvolvidos – é importante salientar que, nesses países, as condições de trabalho são bem melhores do que as nossas – indicando que a morbidade psiquiátrica na família, as experiências de vida e a personalidade são fatores etiológicos mais importantes para os transtornos psiquiátricos em médicos do que os fatores ocupacionais.

Sabe-se que muitas das características psicodinâmicas que conduzem as pessoas para a carreira médica também as predis põem a problemas emocionais e transtornos psiquiátricos. Essas características incluem compulsão, rigidez, falta de controle sobre as emoções, tendência a adiar as oportunidades de gratificações e formação de fantasias irrealistas sobre o futuro.

Johnson,⁵¹ em uma revisão sobre a predisposição dos estudantes de medicina e médicos para os transtornos emocionais e psiquiátricos, destaca o importante papel das experiências de vida na determinação da vulnerabilidade ao estresse ocupacional. Um aspecto relevante nesse tema é o da escolha profissional. Estudos a respeito das motivações dos estudantes para a carreira médica sugerem que, para uma parcela dos estudantes, um dos componentes de sua opção profissional é uma tentativa de reparação de experiências emocionais infantis vinculadas a situações de impotência e/ou abandono emocional. Segundo Johnson,⁵¹ os dois mecanismos básicos envolvidos nas motivações de alguns estudantes para a escolha da carreira médica seriam:

- dar aos outros aquilo que gostariam de ter dado (reparação da impotência)
- dar aos outros aquilo que gostariam de ter recebido (reparação do abandono emocional)

A escolha pela profissão de medicina, nesses casos, seria uma resposta adaptativa a uma vivência de fragilidade e baixa autoestima, que pode levar ao desenvolvimento de alguns problemas profissionais, como:

- relação simbiótica com os pacientes
- aparente frieza ou afastamento emocional dos pacientes
- negação das vulnerabilidades pessoais

Uma das bases da escolha profissional é a vivência de angústia e impotência diante da morte. Assim, uma série de comportamentos dos médicos seria a expressão de mecanismos de defesa ligados a angústias muito primitivas, inerentes ao ser humano, como “[...] o medo da própria destrutibilidade, fragilidade e desamparo”.⁵²

O tema das motivações para a escolha profissional suscita diversas questões. Do ponto de vista psicológico, como era o estudante antes de ingressar na faculdade de medicina? É possível predizer quais estudantes podem vir a ter maiores dificuldades durante o curso de medicina? E depois de se tornarem médicos, quais os mecanismos adaptativos que os médicos utilizam para lidar com os conflitos e as dificuldades na vida adulta?

Em um estudo prospectivo que se tornou clássico na literatura, Vaillant e colaboradores⁵³ investigaram essas questões. Tal estudo comparou a infância de 47 médicos (homens) à infância de 79 profissionais não médicos (homens), socioeconomicamente pareados. Ao longo de 30 anos da vida adulta, o uso de drogas, a estabilidade no casamento, a busca de psicoterapia e os mecanismos utilizados pelos médicos para lidar com crises e conflitos foram comparados com o grupo-controle (não médicos). Os resultados revelaram que os médicos, especialmente aqueles que tinham prática clínica, apresentavam casamentos mais instáveis, usavam drogas e álcool de forma abusiva e buscavam psicoterapia em proporção maior do que os controles.

Ao discutir esses resultados, os autores assinalam que, embora essas dificuldades sejam, com frequência, atribuídas às vicissitudes do exercício da medicina, sua presença ou ausência estava fortemente associada à adaptação na vida anterior à escola médica. Somente os médicos com adaptações instáveis na infância e na adolescência revelaram vulnerabilidade às demandas da profissão.

Quanto aos mecanismos utilizados para lidar com as crises e os conflitos da vida adulta, o estudo detectou que os médicos utilizavam, em uma proporção duas vezes superior à dos controles, os mecanismos de reações hipocondríacas, autoagressão e formação reativa; alguns médicos pareciam ter uma espécie de fobia a procurar ajuda. Além disso, o altruísmo como um tipo de formação reativa também apareceu em uma proporção duas vezes superior à dos controles. Na discussão de seus achados, os autores destacam os seguintes pontos:

- os médicos estudados apresentaram características de personalidade que são habitualmente relacionadas com aquelas encontradas em dependentes químicos: dependência, pessimismo, passividade, insegurança e sentimentos de inferioridade
- a superproteção materna e/ou paterna foi um dado estatisticamente significativo encontrado entre os médicos

- as características de passividade e autoagressão podem até ser “benéficas” para a assistência,
- porém conduzem a baixa qualidade de vida do médico
- a insatisfação conjugal não era devida à carga de trabalho do médico, mas, ao contrário, alguns médicos trabalhavam muito como uma resposta a casamentos infelizes

Em um antigo estudo com médicos dependentes de substâncias narcóticas,⁵⁴ as razões por eles dadas para o uso de drogas eram sobrecarga de trabalho, fadiga crônica e doença física. Os autores, contudo, referem que, ao elaborarem uma história anterior à dependência, encontraram, nos relatos dos médicos, sentimentos de muita revolta em relação aos pais. Mais de 50% dos pais eram referidos como alcoólatras ou consumidores excessivos de álcool, e as mães eram descritas como extremamente nervosas, dominadoras, depressivas, hipocondríacas e cruéis. Concomitantemente, havia a presença de intensos sentimentos de dependência em relação às mães.

Outros dados dessa pesquisa indicavam que os médicos haviam tido diversas doenças na infância, como cólicas intestinais, enurese, asma, obesidade, infecções respiratórias recorrentes e febre reumática. A vida conjugal deles era uniformemente caracterizada por discórdia e infelicidade, sendo que 75% tinham graves dificuldades sexuais com as esposas.

Em resumo, há, na literatura, evidências sugestivas de que uma parcela da população médica seja um grupo de risco em relação a distúrbios emocionais. Esse grupo apresenta, portanto, maior vulnerabilidade psicológica, a qual intervém na escolha profissional e precisa ser considerada no âmbito do planejamento das atividades médicas na graduação, na pós-graduação e na vida profissional.

Medidas preventivas

As medidas preventivas abrangem os níveis de prevenção primária (promoção de saúde e proteção específica), secundária (diagnóstico e tratamento precoces e limitação da incapacidade) e terciária (reabilitação e readequação ocupacional). O Quadro 6.3 apresenta um resumo delas.

QUADRO 6.3

Medidas preventivas

Âmbito	Medidas
Graduação	■ Inclusão de cursos com conteúdo humanístico (Psicologia, Sociologia, Antropologia) ■ Criação de serviços de assistência psicológica/psiquiátrica ■ Incentivo a pesquisas de iniciação científica sobre estresse na formação profissional ■ Implantação de reformas curriculares com criação de tempo livre para o aluno (“áreas verdes”) ■ Grupo de reflexão no internato ■ Oferta e incentivo a atividades culturais e esportivas ■ Desenvolvimento de programas de tutoria
Residência médica	■ Serviço de atendimento psicológico/psiquiátrico ■ Extinção do regime de 36 horas contínuas de trabalho ■ Instituição da folga pós-plantão ■ Garantia de supervisão diuturna ■ Adequação do número de residentes à carga assistencial ■ Suporte de corpo auxiliar

Exercício profissional	■ Conscientização dos docentes e residentes sobre o estresse do treinamento ■ Melhora das condições de trabalho ■ Iniciativas de humanização voltadas aos profissionais ■ Criação de equipes multiprofissionais ■ Conscientização sobre o estresse ocupacional ■ Serviços de consultoria psiquiátrica e psicológica nos hospitais ■ Serviços assistenciais para médicos ■ Programas de atenção à saúde e à qualidade de vida do médico
Vida pessoal	■ Estímulo a hábitos adequados de saúde e prevenção de doenças ■ Conscientização de vulnerabilidades e limitações ■ Reflexão sobre a idealização do papel de médico ■ Conscientização/modificação de atitudes quanto à relação profissão-família-amigos ■ Estímulo a contatos com profissionais não médicos ■ Desenvolvimento de atividades de lazer ■ Estímulo à busca de ajuda profissional

A implantação de medidas profiláticas deve, compulsoriamente, começar por uma medida básica: a inclusão da dimensão psicológica na formação do estudante de medicina.

O trabalho de sensibilização do jovem aluno em relação aos seus aspectos psicológicos – motivações para a profissão, idealização do papel de médico, etc. – e às suas vivências durante o curso de medicina é uma medida de atenção primária, que pode ser concretizada mediante o ensino de psicologia médica.⁵⁵⁻⁵⁷

Diversos recursos pedagógicos têm sido utilizados para o ensino de psicologia médica: grupos de reflexão sobre temas trazidos pelos alunos a partir de situações vividas no processo de profissionalização; entrevistas com indivíduos de diferentes idades, tanto em situação de saúde como de doença; palestras de médicos de várias especialidades para falar sobre os prazeres e desprazeres da vida de médico; *role-playing* do papel de médico e de doente; projeção de filmes; treinamento na linguagem *clown*; e visitas em diferentes cenários de prática, com entrevistas de pacientes, familiares e profissionais.⁵⁵⁻⁵⁷

A tarefa prática central de uma disciplina de psicologia médica é propiciar ao estudante um espaço para entrar em contato com seus sentimentos e suas emoções diante dos seres humanos que está começando a atender. Um espaço que priorize a reflexão e a troca de experiências. Sob diferentes estratégias, trata-se de utilizar a vivência como instrumento de aprendizagem e de semiologia.⁵⁷

O estímulo aos estudantes para a realização de pesquisas de iniciação científica sobre as fontes de estresse no curso médico e os mecanismos adaptativos utilizados pelos estudantes é outra medida recomendada.⁵⁸ Vale destacar também o impacto positivo da implantação de reformas curriculares na redução da ansiedade de estudantes de medicina.⁵⁹

A inclusão de temas sobre o sofrimento psíquico e o estresse psicológico na formação e no exercício profissional é medida particularmente aconselhável de ser implementada durante o internato. Como recurso pedagógico, recomenda-se o uso dos grupos de reflexão,⁶⁰ técnica derivada dos Grupos Balint. Balint,⁶¹ em sua obra, deu ênfase à aliança terapêutica, que deve existir no vínculo profissional-paciente como propulsora de um bom atendimento. Conforme o autor, a técnica, por mais aprimorada que seja, tenderá a ser ou inócua, ou alienante se não for veiculada por uma boa relação profissional-paciente. Para que haja boa relação, é necessário que se dê atenção aos elementos que a compõem, que são, ao mesmo tempo, racionais e irracionais,

realísticos e irrealísticos, maduros e infantis, conscientes e inconscientes. Cassorla⁶² concebe os Grupos Balint como um recurso por meio qual o médico e o estudante de medicina passam a se interessar pelo mundo emocional de seu paciente e pelas repercussões de seu modo de vivê-lo no processo saúde-doença. Como consequência, o médico passaria a se interessar também por sua própria vida emocional, pelas relações humanas em geral e, em particular, pela relação médico-paciente.

O trabalho com grupos de reflexão pressupõe que as possibilidades de mudanças nas atitudes estão diretamente ligadas à intensidade das experiências emocionais vividas no decorrer do processo de ensino ou de trabalho. Assim, as experiências emocionais ligadas à formação e ao exercício profissional compartilhadas em um ambiente afetivo e acolhedor permitem reassegurar a identidade profissional por meio da detecção e do enfrentamento de conflitos e dificuldades.

Ainda no âmbito da formação, recomenda-se a criação de programas de tutoria para estudantes de graduação⁶³ e residentes⁶⁴ e de serviços de assistência psicológica e psiquiátrica para estudantes de graduação,^{52,65-67} residentes^{68,69} e pós-graduandos.⁷⁰

Com relação à residência médica, são medidas prioritárias:

1. organizar programas de recepção aos novos residentes, nos quais são discutidos os principais problemas com que eles irão se deparar e apresentados os recursos institucionais disponíveis
2. garantir supervisão diuturna para os médicos-residentes
3. adequar o número de médicos-residentes à carga assistencial
4. instituir folga pós-plantão
5. garantir suporte do corpo auxiliar (enfermagem, laboratório e outros)
6. extinguir o regime de 36 horas contínuas de trabalho
7. criar serviços de assistência psicológica e psiquiátrica específicos para os residentes
8. conscientizar docentes e residentes sobre o estresse do treinamento

A criação de serviços de consultoria psiquiátrica e psicológica (interconsulta) nos hospitais gerais é medida prioritária.^{71,72} Um conjunto de situações clínicas – estados confusionais agudos associados a diversas patologias orgânicas e ao uso de medicamentos, estados depressivos, pacientes com alto potencial autodestrutivo, atos suicidas e dilemas éticos – representa importantes fontes de estresse para os médicos encarregados da assistência em hospitais gerais. Um serviço de interconsulta pode auxiliar o médico consultante no diagnóstico e no tratamento de pacientes com problemas psicológicos, psiquiátricos e psicossociais, bem como no diagnóstico e no tratamento de disfunções e distúrbios interpessoais e institucionais, envolvendo o paciente, a família e a equipe de saúde.

A criação de equipes interdisciplinares e multiprofissionais nos serviços de saúde, possibilitando a troca de experiências e permitindo compartilhar as difíceis situações que se apresentam nas instituições médicas, é outra medida a ser implantada, com o objetivo de aperfeiçoar a qualidade da assistência e atenuar os efeitos do estresse ocupacional assistencial.

As associações de classe e de especialidades, assim como os órgãos reguladores do exercício profissional, têm um importante papel a desempenhar, informando e estimulando o debate sobre

os fatores de risco para a saúde do profissional e propondo o desenvolvimento de modelos de intervenção nos níveis institucional, grupal e individual.

Denotando a importância que tem adquirido o tema no Brasil, pode-se observar, nos últimos anos, um significativo crescimento de pesquisas⁷³⁻⁸⁵ sobre diversos aspectos (transtornos mentais comuns, depressão, resiliência, empatia, síndrome de *burnout*, assédio moral) relacionados com a saúde mental e a qualidade de vida de estudantes e residentes da área da saúde. Entre os vários estudos em andamento, merecem destaque o projeto VERAS (Vida do Estudante e Residente da Área da Saúde) e o projeto QUARA (Qualidade das Relações no Ambiente Acadêmico), ambos desenvolvidos na Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo (FMUSP).

A crescente conscientização sobre as nossas dificuldades e vulnerabilidades tem propiciado a criação de serviços e programas de atenção à saúde física e mental de estudantes e profissionais da saúde. Entre diversas iniciativas, cabe destacar a implantação de uma rede de apoio aos médicos com dependência química no Estado de São Paulo, que, após dois anos de funcionamento, ampliou sua atuação para dar atenção a médicos com outros problemas emocionais e profissionais.⁵⁰

Como contribuição para o desenvolvimento de pesquisas nessa área, recomenda-se que novos estudos sejam delineados dando ênfase aos seguintes aspectos: 1) caracterização psicossocial dos indivíduos que buscam e exercem profissões da área da saúde (tipos de personalidade, resiliência e vulnerabilidade, mecanismos adaptativos/attitudes diante de estresse; fatores de risco e fatores protetores); 2) caracterização do ambiente de aprendizagem, ou seja, as percepções de estudantes e residentes sobre as práticas educacionais (currículo oficial e currículo oculto) que regem a formação acadêmica e a construção da identidade profissional; e 3) avaliação do impacto de medidas preventivas e interventivas.

REFERÊNCIAS

1. Pitta AMF. Hospital, dor e morte como ofício. São Paulo: Hucitec; 1991.
2. Pitta AMF. Saúde mental e trabalho: a saúde de quem trabalha em saúde. J Bras Psiqu. 1992; 41(1):43-50.
3. Menzies I. O funcionamento das organizações como sistemas sociais de defesa contra as ansiedades. São Paulo: Fundação Getúlio Vargas; 1970.
4. Montanholi LL, Tavares DMS, Oliveira GR. Estresse: fatores de risco no trabalho do enfermeiro hospitalar. Rev Bras Enferm. 2006;59(5):661-5.
5. Rocha MCP, De Martino MMF. O estresse e qualidade do sono nos diferentes turnos hospitalares. Rev Esc Enferm USP. 2010;44(2):280-6.
6. Jodas DA, Haddad MCL. Síndrome de Burnout em trabalhadores de enfermagem de um pronto-socorro universitário. Acta Paul Enferm. 2009;22(2):192-7.
7. Silva ATC, Menezes PR. Esgotamento profissional e TMC em agentes comunitários de saúde. Rev Saúde Pública. 2008;42(5):921-9.
8. Ramalho MAN, Nogueira-Martins MCF. Vivências de profissionais de saúde da área de oncologia pediátrica. Psicol Estud. 2007;12(1):123-32.
9. Rodrigues AB, Chaves EC. Fatores estressantes e estratégias de coping dos enfermeiros atuantes em oncologia. Rev Latino-Am Enferm. 2008;16(1):24-8.
10. Barros DS, Tironi MOS, Nascimento Sobrinho CL, Neves FS, Bittencourt AGV, Almeida AM, et al. Médicos plantonistas de unidades de terapia intensiva: perfil sócio-demográfico, condições de trabalho e fatores associados à síndrome de Burnout. Rev Bras Ter Intensiva. 2008;20(3):235-40.
11. Cavaleiro AM, Moura Junior DF, Lopes AC. Estresse de enfermeiros com atuação em unidade de terapia intensiva. Rev Latino-Am Enferm. 2008;16(1):29-35.
12. Martins JT, Robazzi MLCC. O trabalho de enfermeiro em unidade de terapia intensiva: sentimentos de sofrimento. Rev Latino-Am Enferm. 2009;17(1):52-8.
13. Fogaça MC, Carvalho WB, Cítero VA, Nogueira-Martins LA. Estudo preliminar sobre o estresse ocupacional de médicos e enfermeiros em UTI pediátrica e neonatal: o equilíbrio entre esforço e recompensa. Rev Latino-Am Enferm. 2010;18(1):67-72.
14. Nascimento Sobrinho CL, Barros DS, Tironi MOS, Marques Filho ES. Médicos de UTI: prevalência da síndrome de Burnout, características sociodemográficas e condições de trabalho. Rev Bras Educ Med. 2010;34(1):106-15.
15. De Marco PF, Cítero VA, Moraes E, Nogueira-Martins LA. O impacto do trabalho em saúde mental: transtornos psiquiátricos menores, qualidade de vida e satisfação profissional. J Bras Psiquiatr. 2008;57(3):178-83.
16. Ishara S, Bandeira M, Zuairi AW. Public psychiatry service: job satisfaction evaluation. Rev Bras Psiquiatr. 2008;30(1):38-41.
17. Santos AFO, Cardoso CL. Profissionais de saúde mental: manifestação de stress e Burnout. Estud Psicol (Campinas). 2010;27(1):67-74.

18. Machado MH. Os médicos no Brasil: um retrato da realidade. Rio de Janeiro: FIOCRUZ; 1997.
19. Carneiro MB, Gouveia VV, coordenadores. O médico e o seu trabalho: aspectos metodológicos e resultados do Brasil. Brasília: Conselho Federal de Medicina; 2004.
20. Nascimento Sobrinho CL, Carvalho FM, Nascimento MA. Transformação na organização do trabalho médico no Brasil. Rev Baiana Saúde Pública. 2004;28(1):78-90.
21. Nascimento Sobrinho CL, Carvalho FM, Bonfim TAS, Cirino CAS, Ferreira IS. Condições de trabalho e saúde mental dos médicos de Salvador, Bahia, Brasil. Cad Saúde Pública. 2006;22(1):131-40.
22. Barbosa GA, Andrade EO, Carneiro MB, Gouveia VV, coordenadores. A saúde dos médicos no Brasil. Brasília: Conselho Federal de Medicina; 2007.
23. Scheffer M, coordenador. Demografia médica no Brasil 2015. São Paulo: Departamento de Medicina Preventiva da Faculdade de Medicina da USP; Conselho Regional de Medicina do Estado de São Paulo; Conselho Federal de Medicina; 2015.
24. Smith S. Why are doctors so unhappy? BMJ. 2001;322:1073-4.
25. Edwards N, Kornacki MJ, Silversin J. Unhappy doctors: what are the causes and what can be done? BMJ. 2002;324:835-8.
26. Nogueira-Martins LA, Nogueira-Martins MCF. O exercício atual da medicina e a relação médico-paciente. Rev Bras Clín Terap. 1998;24(2):59-64.
27. Freudenberger HJ. Staff burn-out. J Soc Issues. 1974;30(1):159-65.
28. Freudenberger HJ. The staff burnout syndrome in alternative institutions. Psychother Theory Res Pract. 1975;12(1):73-82.
29. Maslach C, Jackson S. Maslach Burnout inventory. Palo Alto: Consulting Psychologist; 1986.
30. Pereira AMTB, editora. Burnout: quando o trabalho ameaça o bem-estar do trabalhador. São Paulo: Casa do Psicólogo; 2002.
31. Rodrigues AL, Campos EMP. Síndrome do Burnout. In: Mello Filho J, Burd M, editores. Psicossomática hoje. 2. ed. Porto Alegre: Artmed; 2010. p.135-52.
32. Maslach C, Schaufeli WB, Leiter MP. Job Burnout. Annu Rev Psychol. 2001;52:397-422.
33. Karasek R. Job demand, job decision latitude, and mental strain: implications for job redesign. Admin Sci Quart. 1979;24:285-308.
34. Canadian Medical Association. CMA guide to physician health and well-being: facts, advice and resources for canadian doctors. Ottawa: Medical Association; 2003.
35. International Conference on Doctors' Health: Doctors' Health Matters – finding the balance; 2008 Nov 17-19; London, England. London: BMA House; 2008.
36. Clever LH. A saúde do médico. In: Beeson PB, McDermott W, editores. Cecil-Loeb: tratado de medicina interna. 16. ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan; 1990.
37. Casas M. Programa de atenção aos médicos doentes da província da Catalunha, Espanha. Anais do 22. simpósio sobre atenção à saúde mental do médico; 2004 Out 16-18, Salvador; 2004. Salvador: Congresso Brasileiro de Psiquiatria; 2004.

38. Kaufman M. Programa de atenção à saúde do médico da Província de Ontário, Canadá. Anais do 22. simpósio sobre atenção à saúde mental do médico; 2004 Out 16-18; Salvador; 2004. Salvador: Congresso Brasileiro de Psiquiatria; 2004.
39. Nogueira-Martins LA. Atividade médica: fatores de risco para a saúde mental do médico. Rev Bras Clín Terap. 1991;20:355-64.
40. Nogueira-Martins LA, Jorge MR. Natureza e magnitude do estresse na residência médica. Rev Ass Med Bras.1998;44(1):28-34.
41. Nogueira-Martins LA. Residência médica: estresse e crescimento. São Paulo: Casa do Psicólogo; 2005.
42. Firth-Cozens J. Doctors: their well being and their stress. BMJ. 2003;26:670-1.
43. Center C, Davis M, Detre T, Ford DE, Hansbrough W, Hendin H, et al. Confronting depression and suicide in physicians - a consensus statement. JAMA. 2003;289(23):3161-6.
44. Shanafelt TD, Balch CM, Dyrbye L, Bechamps G, Russell T, Satele D, et al. Suicidal ideation among American surgeons. Arch Surg. 2011;14(1):54-62.
45. Palhares-Alves HN, Palhares DM, Laranjeira RR, Nogueira-Martins LA, Sanchez ZM. Suicide among physicians in the state of Sao Paulo, Brazil, across one decade. Rev Bras Psiquiatr. 2015;37(2):146-9.
46. Dyrbye LN, Thomas MR, Shanafelt TD. Systematic review of depression, anxiety and other indicators of psychological distress among U.S. and Canadian medical students. Acad Med. 2006;81(4):354-73.
47. Puthran R, Zhang MWB, Tam WW, Roger C Ho RC. Prevalence of depression amongst medical students: a meta-analysis. Med Educ. 2016;50:456-68.
48. Toews JA, Lockyer JM, Dobson DJG, Simpson E, Brownnell AKW, Brenneis F, et al. Analysis of stress levels among medical students, residents, and graduate students at four Canadian schools of medicine. Acad Med. 1997;72:997-1002.
49. Alves HNP, Surjan JC, Nogueira-Martins LA, Marques ACRP, Ramos SP, Laranjeira RR. Perfil clínico e demográfico de médicos com dependência química. Rev Ass Med Bras. 2005;51(3):139-43.
50. Palhares-Alves HN, Laranjeira R, Nogueira-Martins LA. A pionnering experience in Brazil: the creation of a support network for alcohol and drug dependent physicians. A preliminary report. Rev Bras Psiquiatr. 2007;29(3):258-61.
51. Johnson WDK. Predisposition to emotional distress and psychiatric illness amongst doctors: the role of unconscious and experimental factors.Br J Med Psychol. 1991;64:317-29.
52. Millan LR, De Marco OLN, Rossi E, Arruda PV. O universo psicológico do futuro médico. São Paulo: Casa do Psicólogo; 1999.
53. Vaillant GE, Sobowale NC, Mcarthur C. Some psychologic vulnerabilities of physicians. N Eng J Med. 1972;287(8):372-5.
54. Modlin HC, Montes A. Narcotic addiction in physicians. Am J Psychiatry. 1964;121:358-65.

55. Kaufman A, editor. De estudante a médico: a psicologia médica e a construção de relações. São Paulo: Casa do Psicólogo; 2011.
56. Nogueira-Martins MCF. Humanização das relações assistenciais: a formação do profissional de Saúde. São Paulo: Casa do Psicólogo; 2004.
57. Botega NJ, Nogueira-Martins LA. Hipócrates doente: os dramas da psicologia médica. *Monit. Psiquiatr.* 1997;3(4):30-1.
58. Silva FB, Mascia AR, Lucchese AC, De Marco MA, Nogueira-Martins MCF, Nogueira-Martins LA. Atitudes frente a fontes de tensão do curso médico: um estudo exploratório com alunos do segundo e do sexto ano. *Rev Bras Educ Med.* 2009;33(2):230-9.
59. Zuardi AW, Prota FDG, Del-Ben CM. Reduction of the anxiety of medical students after curricular reform. *Rev Bras Psiquiatr.* 2008;30(2):136-8.
60. Zimerman DE. A formação psicológica do médico. In: Mello Filho J. *Psicossomática hoje*. São Paulo: Artes Médicas; 2010.
61. Balint M. O médico, seu paciente e a doença. Rio de Janeiro: Atheneu; 1988.
62. Cassorla RMS. Dificuldades no lidar com aspectos emocionais da prática médica: estudo com médicos no início de grupos Balint. *Rev ABPAPAL.* 1994;16(1):18-24.
63. Bellodi PL, Martins MA. Tutoria: mentoring na formação médica. São Paulo: Casa do Psicólogo; 2005.
64. Marcolino JAM, Vieira JE, Piccinini Filho L, Mathias LAST. Tutoria com médicos residentes em anesthesiologia: o programa da Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de São Paulo. *Rev Bras Anesthesiol.* 2004;54(3):438-47.
65. Millan LR, Souza EM, De Marco OLN, Rossi E, Arruda PV. O I Encontro Paulista dos Serviços de Assistência Psicológica ao Estudante Universitário. *Rev Hosp Clín Fac Med S Paulo.* 1998;53(3):156-61.
66. Millan LR, Arruda PCV. Assistência psicológica ao estudante de medicina: 21 anos de experiência. *Rev Assoc Med Bras.* 2008;54(1):90-4.
67. Baldassin S, editor. Atendimento psicológico aos estudantes de medicina - técnica e ética. São Paulo: EDIPRO; 2012.
68. Nogueira-Martins LA, Stella RCR, Nogueira HE. A pioneering experience in Brazil: the creation of a center for assistance and research for medical residents (NAPREME) at the Escola Paulista de Medicina, Federal University of São Paulo. *São Paulo Med J.* 1997;115(6):1569-72.
69. Fagnani Neto R, Obara CS, Macedo PCM, Cítero VA, Nogueira-Martins LA. Clinical and demographic profile of users of a mental health system for medical residents and other health professionals undergoing training at the Universidade Federal de São Paulo. *São Paulo Med J.* 2004;122(4):152-7.
70. Nogueira-Martins LA, Fagnani Neto R, Macedo PCM, Cítero VA, Mari JJ. The mental health of graduate students at the Federal University of São Paulo: a preliminary report. *Braz J Med Biol Res.* 2004;37(10):1519-24.
71. Nogueira-Martins LA, Botega NJ. Interconsulta psiquiátrica no Brasil: desenvolvimentos recentes. *Rev ABPAPAL.* 1998;20(3):105-11.

72. Nogueira-Martins LA. Interconsulta hoje. In: Mello Filho J, Burd M, editores. *Psicossomática hoje*. 2. ed. Porto Alegre: Artmed; 2010. p.160-4.
73. Lima MCP, Domingues MS, Ramos-Cerqueira ATB. Prevalência e fatores de risco para transtornos mentais comuns entre estudantes de medicina. *Rev Saúde Pública*. 2006;40(6):1035-41.
74. Guimarães KBS, editor. *Saúde mental do médico e do estudante de medicina*. São Paulo: Casa do Psicólogo; 2007.
75. Baldassin S, Alves TC, de Andrade AG, Nogueira Martins LA. The characteristics of depressive symptoms in medical students during medical education and training: a cross-sectional study. *BMC Med Educ*. 2008;8:60-8.
76. Paro HBMS, Morales NMO, Silva CHM, Rezende CHA, Pinto RMC, Morales RR, et al. Health-related quality of life of medical students. *Med Educ*. 2010;44(3):227-35.
77. Nogueira-Martins LA. Qualidade de vida dos médicos residentes: revisão de estudos brasileiros. *Cad ABEM*. 2010;6:12-8.
78. Leão PBOS, Nogueira-Martins LA, Menezes PR, Bellodi PL. Well-being and help-seeking: an exploratory study among final-year medical students. *Rev Assoc Med Bras*. 2011;57(4):379-86.
79. Baldassin S, Silva N, de Toledo Ferraz Alves TC, Castaldelli-Maia JM, Bhugra D, Nogueira-Martins MCF, et al. Depression in medical students: cluster symptoms and management. *J Affect Disord*. 2013;150(1):110-4. .
80. Nogueira-Martins MF, Lima-Costa D, Nogueira-Martins LA, Nogueira-Martins MCF. Perceptions of healthcare undergraduate students about a hospital clown training. *Creative Education*. 2014;5(8):542-51.
81. Costa EFO, Rocha MMV, Santos ATRA, Melo EV, Nogueira-Martins LA, Andrade TM. Common mental disorders and associated factors among final-year healthcare students. *Rev Assoc Med Bras*. 2014;60(6):525-30.
82. Paro HBMS, Silveira PSP, Perotta BG, Enns S, Giaxa RRB, Bonito RF, et al. Empathy among medical students: is there a relation with quality of life and burnout? *PLoS ONE*. 2014;9(4):e94133.
83. Barreto ADAL, Babler F, Quaresma IYV, Arakaki JNL, Peres MFT. Projeto QUARA: prevalência de abusos, maus-tratos e outras agressões durante a formação médica: um estudo de corte transversal em São Paulo, Brasil, 2013. *Rev Med (São Paulo)*. 2015;94(1):6-14.
84. Tempiski P, Santos IS, Mayer FB, Enns SC, Perotta B, Paro HB, et al. Relationship among medical student resilience, educational environment and quality of life. *PLoS One*. 2015;10(6):e0131535.
85. Enns SC, Perotta B, Paro HB, Gannam S, Peleias M, Mayer FB, et al. Medical students' perception of their educational environment and quality of life: is there a positive association? *Acad Med*. 2016;91(3):409-17.



Interconsulta psiquiátrica: visão psicodinâmica

Neury José Botega

Este capítulo considera o encaminhamento ao psiquiatra um processo a ser compreendido em sua vertente psicodinâmica. A tríade formada pelo paciente, seu médico e o psiquiatra configura um campo relacional influenciado tanto por crenças e sentimentos pessoais quanto por normas institucionais explícitas e implícitas. Esses aspectos devem ser utilizados pelo consultor como instrumento de avaliação e de orientação da ação. A formulação de um diagnóstico situacional considera tanto a presença de um transtorno psiquiátrico quanto de estressores psicossociais, dificuldades da relação médico-paciente e aspectos da instituição que interferem na assistência prestada aos doentes. O estudo dos encaminhamentos em um referencial psicodinâmico amplia a visão sobre vários aspectos da prática médica, abrindo um campo de investigação multidisciplinar. Ao longo do capítulo, são transcritos trechos de entrevistas realizadas com 50 médicos do Hospital das Clínicas da Unicamp a respeito da relação deles com a psiquiatria.¹

Os encaminhamentos entre profissionais da saúde fazem parte de um contínuo fluxo de pacientes para dentro e para fora da vida de um médico. Independentemente dos aspectos clínicos envolvidos, os encaminhamentos preenchem propósitos sociais e psicológicos. Sob um ponto de vista antropológico, a totalidade do processo poderia ser concebida como um ritual de cura que se tornou parte de nossa cultura. A opinião de um especialista é rodeada por expectativas de parte do médico que encaminha, do paciente e de seus familiares. Conseguir a consulta, deslocar-se, ser examinado por um profissional idealizado, tudo isso pode equivaler a um esforço de peregrinação em busca da cura. Visto assim, o encaminhamento ao especialista preencheria um propósito sociocultural, independentemente dos aspectos racionais nele envolvidos.²

Uma rede de encaminhamentos realizados e recebidos é importante na estruturação de um sentido de identidade profissional e no desenvolvimento de defesas contra a ansiedade. Ao atender um paciente que lhe foi encaminhado, o profissional recebe informações sobre o que o colega médico comentou sobre seu trabalho, sobre sua pessoa. Essas informações são trazidas espontaneamente pelos pacientes ou perscrutadas pelo profissional, que, assim, vai formando sua identidade profissional. Recebendo e fazendo encaminhamentos, o profissional da saúde define o que quer e o que tem condições de tratar.

No âmbito do hospital geral, a filosofia do que, no princípio, era entendido como uma consulta comum, com a ação orientada para o paciente e envolvendo pouco ou nenhum contato com a equipe de saúde, veio passando por transformações. Ferrari e colaboradores³ lembram que a tarefa dos serviços de psiquiatria em hospitais gerais orientou-se inicialmente “para fora”, fazendo seleção e distribuição de pacientes para hospitais psiquiátricos ou por meio de atendimento ambulatorial. Com a ação da interconsulta, a tarefa do psiquiatra voltou-se para dentro da instituição, aprimorando a assistência aí prestada.

As situações que desencadeiam a interconsulta trazem elementos da organização da equipe de profissionais e da instituição que interferem sobremaneira na tarefa assistencial. Quando chega a uma enfermaria, o psiquiatra passa a ser um observador participante do que está acontecendo entre as pessoas pertencentes a um grupo operacional, em que o paciente deve ser a figura

central. Pode-se detectar uma série de mecanismos psicológicos subjacentes ao funcionamento dos grupos e da instituição: “[...] cada interconsulta é uma verdadeira radiografia institucional, que revela aspectos não explicitados de seu funcionamento e sua organização”.⁴

Poderíamos ir além em nossa análise do processo de encaminhamento ao psiquiatra no âmbito institucional, concebendo o hospital geral como um espaço social terapêutico, uma organização na qual se corporificam numerosas instituições. Justamente por ser um espaço de entrecruzamento institucional, está sujeito às múltiplas influências de natureza política, econômica e ideológica do conjunto social.^{5,6} Portanto, o contato com o paciente e o relacionamento entre profissionais poderiam ser entendidos em termos de relações sociais mais amplas, em oposição ao pensamento idealista de soluções isoladas do conhecimento técnico. Surgiria, assim, uma estrutura macrosocial inteira subjacente à prática médica, que deslinda as implicações que os fatores sociopolíticos e econômicos têm na evolução de uma enfermidade e no processo de encaminhamento a um especialista.

ENCAMINHAR PARA UM PSIQUIATRA

A relação médico-paciente é sempre e invariavelmente o resultado de um compromisso entre as “ofertas” e as exigências do paciente e as respostas do médico.⁷ Quando é atendido por um médico, o paciente espera ser acolhido e examinado, ser informado sobre o que se passa com ele e, depois disso, receber um tratamento que resolva ou amenize seus problemas. Se algum passo desse processo não sair a contento, o paciente poderá demandar novos exames e tratamentos ou ser encaminhado a um especialista para avaliação mais sofisticada. O médico, por sua vez, espera que seu paciente se comporte como tal, que tenha um problema que possa ser diagnosticado, para o qual conheça um tratamento que se mostre eficaz.

Quando o que acontece em uma consulta foge dessas expectativas, desencadeia-se uma crise de confiança na relação estabelecida entre médico e paciente. Tomado tanto por certo grau de incerteza quanto por um sentido de responsabilidade pelo paciente, o médico pode, então, decidir-se pelo encaminhamento a um especialista. Entendido assim, o encaminhamento surge a partir desse caráter transacional, cristalizando uma série de trocas empreendidas no encontro entre médico e paciente:

Tem paciente que é chato, que não acredita, que questiona. Acha que [a gente] é aluno, que tá enrolando [...]. O paciente acha que a gente tá enrolando, mesmo quando tem maior vínculo. Até complica, fica olhando: “como é?”.

Depende do que a gente sente. Tem pacientes que confiam em você. Então dá pra gente tentar conversar e trabalhar aquilo tranquilamente. Mas, às vezes, não tem condições [...]

Às vezes parece que eles não estão confiando, acreditando no médico. Querem fazer exames de sangue, já foram várias vezes a outros médicos, muito pesquisados. Ficam sem acreditar mesmo que a problemática seja emocional. Às vezes, a gente dá alta, mesmo: “procure novamente o ambulatório só se for realmente preciso!”.

A própria existência de uma especialidade implica, para os que não são especialistas, um limite no campo de atuação profissional e um abalo no desejo do médico de propiciar tratamento integral a seus pacientes. Além do mais, enquanto o sucesso auferido no tratamento aumenta a realização profissional, a necessidade de encaminhar para um colega especialista ocorre em situações de incerteza e de resultados terapêuticos pobres.⁸

O médico pode tomar a necessidade de um encaminhamento como uma experiência ativa e de crescimento profissional, discriminando a problemática do paciente de seus próprios sentimentos. Mas também pode vivenciá-la passivamente, no sentido de se submeter a uma imposição e se ver tomado por insegurança quanto a sua capacidade e ao seu carisma. Se possível, não gostaria de depender de outro profissional.

Haveria algo de peculiar ao se encaminhar um paciente para um especialista em saúde mental? Haveria diferenças consideráveis entre o encaminhamento de pacientes para um psiquiatra e o encaminhamento para especialistas de outras áreas? Parece que sim. Como sugerido por Ferrari e colaboradores,³ entre o médico que encaminha e o psiquiatra interconsultor geralmente existem diferenças quanto a critérios de saúde, ideologia, linguagem técnica, modelo de ação e objetivos.

Os especialistas não pertencentes à área de saúde mental têm seu limite de ação mais restrito a um campo técnico, geralmente sem exceder a competência particular e específica da especialidade. O psiquiatra ou o psicólogo, diferentemente, colocam sob avaliação a própria

relação que se estabelece entre o médico e seu paciente. Isso ocorre porque uma avaliação psicológica cabal não pode omitir nenhuma das relações importantes do paciente, inclusive a que ele mantém com seu médico. Isso pode, de alguma forma, intimidar quem encaminha.^{7,9} Por isso, não raramente, a necessidade da avaliação do psiquiatra pode provocar reações de desconfiança:

Confio muito [nos psiquiatras daqui]. Por outro lado, a gente tem visto que os psiquiatras encontram problemas demais... Opa! Não sei se isso existe, ou tá na cabeça do profissional!

Entre as várias resistências ao encaminhamento, pode haver o temor de ser tomado como incompetente para lidar com casos corriqueiros de transtornos mentais ou crises emocionais. A necessidade de pedir ajuda pode ser percebida como uma derrota, afetando a autoestima. Há, ainda, o temor de que algo orgânico que passou inadvertido seja descoberto pelo psiquiatra e se manifeste de forma trágica mais tarde. Esses temores podem conduzir à minimização da problemática psicológica dos pacientes.

Outra condição peculiar relaciona-se ao receio do médico de que pacientes e familiares reajam negativamente à indicação de uma avaliação psiquiátrica. A suposta objeção do paciente e de familiares leva alguns médicos a encaminharem ao neurologista ou ao psiquiatra, mas referindo-se a este último como “neurologista”. É comum, também, na prática institucional, atendermos pacientes que se surpreendem quando nos identificamos como psiquiatras. Seu médico não lhes havia dito isso.

O encaminhamento elaborado

O limite de tolerância de um médico diante de um paciente com distúrbios comportamentais ou emocionais é algo individual. A consulta psiquiátrica tende a ser evitada, pelo menos até o ponto em que o paciente perturbe gravemente seu tratamento ou provoque considerável grau de incerteza no médico.¹⁰ Cada médico teria um limiar de encaminhamento influenciado por vários fatores, entre os quais estão traços de personalidade, treinamento recebido na graduação, experiência, tolerância à incerteza, senso de autonomia e interesse, sobrecarga de trabalho e conflitos pessoais. Alguns exemplos são:

Não sei... São aqueles pacientes [os encaminhados] com quem já tentei conversar por uma, duas consultas mais longas [...]. Não me sentindo satisfeita, encaminho.

Eu sempre procurei resolver as coisas pelo lado mais prático, mais simples, deixando o emocional para segundo plano. Então, as pessoas que rodeiam muito e têm dificuldade de trabalhar isso, eu tenho muita dificuldade e acabo encaminhando por causa disso [...]. Outros que a gente encaminha são aqueles que acabam te aborrecendo de alguma forma, porque diferem muito da tua personalidade, personalidade de quem tá atendendo.

No *encaminhamento elaborado*, médico e paciente se convencem de que é melhor pedir a ajuda de um profissional de saúde mental. Eles terão conversado francamente sobre isso, inclusive sobre seus receios e expectativas. A ideia de encaminhar um paciente ao psiquiatra pode não ocorrer de imediato, em uma primeira consulta. É algo que vai sendo elaborado ao longo de alguns encontros. No decorrer de sua relação com o paciente, o médico vai tomando consciência das próprias limitações e passa a avaliar suas possibilidades terapêuticas. Tal elaboração, via de regra, passa pelas seguintes etapas: espera-se chegar a uma conclusão na

investigação clínica, tenta-se o uso de medicamentos antidepressivos ou ansiolíticos, procura-se, pelo diálogo, influenciar o paciente:

A gente acaba tentando resolver bem rapidinho, no consultório, com panos quentes, e acaba não encaminhando.

Encaminho com muita frequência. Não digo com exagero. Mas aqueles doentes para quem, usando do direito e do estilo paternal que o médico tem no consultório, e que de forma coloquial eu dou conselhos de regra prática da vida e isso não provoca uma resposta favorável em curtíssimo prazo, invariavelmente, encaminho.

O encaminhamento elaborado exige uma espécie de estratégia de aproximação. O exemplo a seguir ilustra o que pode acontecer no consultório de um médico clínico ao longo de duas ou três consultas:

[...] ou então, supostamente cardíacos, que não são. São pacientes ansiosos. É muito comum mulher, desajuste matrimonial. Não vou muito a fundo nisso. Mas duas, três consultas, e você chega lá, né? Na primeira consulta, não, ela quer saber se tem um problema no coração. E eu também. Na segunda ou terceira consulta, se ela tem um eletrocardiograma normal, se tem prolapso. Então, eu pergunto assim pra moça: “E em casa, tudo bem?”. “É, tudo bem...” “E os filhos, dão muito trabalho?” “É, dão...” “E o marido?” “Meu marido é um santo!”

Todas falam isso. Aí eu já penso: “então tá, desgraçada! Quer dizer, então, que o marido é bão?”. “É, não deixa faltar nada em casa, trabalhador [...]” Mas a vida sexual é terrível. Então, é trabalhador, geralmente de uma multinacional, faz umas horas extras, sai do trabalho, passa no boteco, toma umas três ou quatro cachaças, em casa bebe mais um pouco e deita na cama de botina. Sábado vai no *snookinho*, bebe mais ainda [...] E ela fica lá, né.

Mas hoje o negócio tá muito diferente, pois a mulher vê novela, revista, conversa com a vizinha e pensa: “Pô, e eu aqui, como é que é o negócio?” Tem muita ansiedade. Talvez eu e o psiquiatra possamos ajudá-la no seguinte: mostrando pra ela que ela tem um problema. Que, às vezes, as pessoas desconhecem isso. (Que nem aquele camarada que viveu 30 anos angustiado e depois descobriu que estava angustiado porque não gostava do serviço. Agora, se o psicólogo falar pra ele sair do serviço, ele responde: “Como? Vou me aposentar logo, vou sair do serviço [...] Vou viver de quê?”.) Então, o que pode acontecer com essa mulher? Largar do marido e pegar outro, sei lá [...] Mas pode ser que ela não saiba do problema dela, não saiba que ela tem um problema [...].

A decisão de pedir ajuda pode, no entanto, ter sido postergada ao máximo. Ocorre, então, de essa decisão ser tomada em um momento em que o médico já atingiu seu limite de suportar a angústia desencadeada pela situação. Quando toma essa decisão, quer a presença urgente do psiquiatra, pois tal é sua aflição. Costuma ser difícil delimitar o que mais pesa no *caráter de urgência* de alguns encaminhamentos: o problema do paciente ou a necessidade do médico.⁸

O encaminhamento automático (“passei a bola pra frente... Me livre!”)

Nos encaminhamentos “automáticos”, parece ocorrer um curto-circuito na relação médico-paciente, impedindo que o processo de tomada de decisão em relação à necessidade do auxílio de um especialista siga um curso normal. Algo trazido pelo paciente repercute profundamente no médico, que, de forma apressada, procura encaminhar sua angústia e responsabilidade para outro profissional:

Quando a coisa tá muito fora do meu conhecimento, do meu controle, isso me angustia, e a minha primeira atitude, a única coisa que passa na minha cabeça e que eu tento fazer, é passar a bola pra frente. Isso é típico.

A paciente teve um ataque, me xingando de estúpida, grosseira. Foi gozado ver minha desorganização. Chamei a psiquiatria, atordoada. É difícil pra gente poder aceitar que vai ficar cuidando do problema psicológico dela. Não aceitava a reação

emocional dela [...].

Acho que o encaminhamento em geral, não só para a psiquiatria, é um “me livrei”, passei pra outro.

É comum a realização de múltiplos encaminhamentos, às vezes, todos ao mesmo tempo. O paciente sai do consultório com um monte de papeizinhos, tão aturdido quanto o médico que o atendeu. Nessa conduta, podemos pensar que há, de parte do médico, uma espécie de “pulverização” da angústia despertada pelo atendimento. Encaminhamentos desse tipo geralmente acontecem quando o paciente manifesta várias queixas corporais:¹¹

Veja bem, fui treinado para ser um médico que trata do orgânico [...], mas o que gostaria de dizer pra você é que, quando não se identifica, desde logo, uma sequência de eventos que provoque na minha mente um raciocínio fisiopatológico, e desde que o doente, por força das circunstâncias, dê a sua transmissão da queixa uma proximidade quase estéril, isso, vamos dizer assim, grosseiramente, acaba aborrecendo e impede o raciocínio clínico. Eu me preparei para um determinado objetivo.

É difícil, muito difícil. A gente sempre... o médico sempre quer descobrir as causas. Não tem por onde começar [...]. É angustiante, fica bloqueado, não consegue fazer mais nada. Devia ser obrigatório [sorrindo] ao chegar ao consultório: “queixa principal?”.

Como o paciente não oferece uma prioridade ao médico, este fica bloqueado, angustia-se e só consegue ver uma profusão de queixas, geralmente dores “sem sentido” (vale dizer, sem base orgânica detectável). A apresentação de vários sintomas corporais, sem se fixar a uma queixa principal, leva a um bloqueio do raciocínio clínico, com angústia do médico. Já para o paciente fixado a queixas corporais, deve haver algum problema sim, mas, como o médico não encontrou nada, a “culpa”, então, passa a ser do médico. Assim, após o deslocamento de seus conflitos para o espaço corporal, projeta-os no médico.

O desvendar dessa trama em que médico e paciente se envolvem está condicionado ao reconhecimento de que o sofrimento de uma pessoa não tem sua realidade localizada unicamente em um espaço corporal anônimo, mas em um espaço diferente: o espaço das relações do indivíduo com seu mundo interior e com a totalidade de sua vida. E essa possibilidade de reconhecer o outro permite que ele mesmo, o paciente, veja-se reconhecido, mudando a organização de seu padecimento.¹²

Se essa transposição de linguagem não se opera, o médico passa a se sentir irritado e frustrado. Depois de encontrar um rótulo para a problemática do paciente, cada médico elege o que vai tratar e o que vai encaminhar. É algo, nesse sentido, automático, inconsciente.

O relacionamento rejeitado não deixa de ser uma relação, da qual o encaminhamento pode surgir como um verdadeiro *acting out*, servindo de conduta de descarga, tanto para o médico quanto para o paciente. A seguinte frase, de Sarano,¹³ parece resumir bem o sentido de alguns encaminhamentos: “Cada um se livra como pode e livra o que pode”.

Alguns autores consideram má utilização do encaminhamento quando ele é feito exclusivamente porque o nível de tolerância foi excedido, vendo, nessa atitude, o resultado de sentimentos de hostilidade e de punição dirigidos ao paciente.¹⁴ Certos encaminhamentos são, antes, uma atitude de defesa do médico do que, propriamente, uma preocupação com o benefício que um especialista poderia trazer para o paciente. Nessas condições, o encaminhamento ao psiquiatra pode ter, de fato, conotação de punição a um paciente que não se ajustou ao esquema

referencial do médico. Pode funcionar, também, como uma espécie de confirmação de que “nada mais poderia ser feito pelo paciente, mesmo”.

O “me livrei” do médico pode passar apenas por ato de esperteza, livrar-se de algo difícil e passá-lo para outro profissional. Esse tipo de encaminhamento comumente produz, em quem o recebe, uma sensação de raiva, de ser usado e explorado por um colega que se vale de um “passar a bola pra frente” para definir sua clientela. No entanto, nem sempre é esse o caso, como a seguir:

Alcoolista eu mando todos. Lá na minha faculdade todo alcoolista que eu atendia mandava [para a psiquiatria]. Eu sofria, pois realmente eu não consigo fazer uma relação com alcoolista. Então encaminho, sabe [...].

Alguns encaminhamentos “automáticos” não significam apenas descaso ou intenção consciente de punir. Parecem, antes, reações contratransferenciais despertadas pelo contato com o paciente, que podem ser acompanhadas de sentimento de culpa do médico, culpa ante o fato de seus exames mais conscientes e apurados não propiciarem verdadeira luz sobre as doenças nem alívio para o doente. Às vezes, acontece de o médico encaminhar o paciente guardando a sensação de que este não terá melhor sorte com o colega:

Muito desses casos [frigidez] encaminho pra “gineco”. Ao mesmo tempo, sei que eles não vão dar uma solução [...].

O encaminhamento “bomba-relógio”

Por meio de teorias que o médico vai dominando e da prática profissional, seu poder de racionalização é reforçado, mas isso não o livra do temor que a ideia da doença e da morte pode produzir.¹⁵ Em conversas informais, os médicos em geral manifestam o temor a certas doenças. É de se supor que, além dessas conscientemente lembradas, existam outras, em nível inconsciente, algumas mais suportáveis e outras ainda mais preocupantes e temidas:

Paciente terminal... e aí a gente joga a bomba pro psiquiatra. Eu não acho isso correto também, só que, às vezes, a gente não tem estrutura pra assumir. Então a gente precisa de uma orientação [...].

Em muitas situações, ao encaminhar certos pacientes, os médicos estão procurando manter um perigo distante, fora de si, projetado no outro e sendo cuidado por outro também. No dizer de um colega, referindo-se a alguns pacientes terminais, “joga-se a bomba” para o psiquiatra. A projeção, agora, vai adiante, e a angústia é depositada naquele que receberá o encaminhamento.

Ao comentar sobre esse caráter projetivo dos encaminhamentos, Bourne¹⁶ sugere que os médicos precisam ter seus pacientes e sua clientela em geral para representar e conter objetos que lhes são essenciais, mas difíceis de serem mantidos em seu mundo interno. Precisamos manter nossos objetos ao nosso redor, projetados e a distância, talvez, mas precisamos deles aí. A maneira como um médico dispõe seus pacientes, perto ou longe de si, tem a ver com a estrutura de seu mundo interno e do mundo que ele constrói para si mesmo.

O paciente encaminhado passa a representar o emissário de uma bomba-relógio carregada de sentimentos muito difíceis de serem mantidos no mundo interno do médico. São, geralmente, casos de pacientes terminais, pacientes submetidos a procedimentos altamente invasivos, aqueles

que não evoluem segundo a expectativa inicial da equipe assistencial. Ou, então, a “bomba” é a representação de algo trágico a ser revelado para o paciente e os familiares.

Tais encaminhamentos nem sempre significam uma ruptura na relação médico-paciente. Ao contrário, podem significar falta momentânea de condições de continência e refletem a responsabilidade (geralmente com sentimentos de culpa) que o médico e toda a equipe assistencial sentem em relação ao paciente. Ao chegar à enfermaria, o psiquiatra percebe que todos estão muito apreensivos, a sua espera, com muita necessidade de falar. Não raramente, para sua surpresa, o paciente encontra-se mais tranquilo do que médicos e enfermeiras.

Nesses casos, o interconsultor corre o risco de se identificar com o colega ou com a equipe que está atendendo o paciente. Pode, então, contaminar-se com a angústia que envolve a equipe assistencial, deixando de discriminar os diferentes aspectos envolvidos na situação e ficando impedido de atuar terapeuticamente.

É necessário opor-se às pressões que recebe para agir rapidamente e deixar-se guiar tanto pelos elementos objetivos que coleta quanto por sua intuição clínica. Durante esse processo, naturalmente vai-se ampliando a compreensão do comportamento apresentado pelo paciente e das reações da equipe assistencial. Isso costuma restaurar a capacidade de continência da equipe em relação ao paciente e aos sentimentos por todos vivenciados.

O Capítulo 5 aprofunda-se nas nuances da relação entre médicos. Aqui, por ora, relembramos que o psiquiatra interconsultor é chamado para intervir em condições de resultados terapêuticos pobres. Sua entrada em cena pode ser percebida como benéfica e apoiadora ou, contrariamente, como reforçadora de um sentimento de baixa autoestima.

O que se requer do interconsultor é um apoio não específico ao ego. Esse apoio deve ser prestado com muito tato, para que o consulente não seja ainda mais debilitado pelo reconhecimento explícito de suas dificuldades, em um contexto que poderá acarretar uma perda ainda mais profunda de autoconfiança e amor próprio.

O interconsultor pode ajudar o médico a entender os significados que a conduta do paciente provoca e como suas respostas (do médico), por sua vez, fecham um círculo vicioso que pode ser potencialmente destrutivo. O médico pode encontrar considerável alívio ao conhecer, por meio do interconsultor, os motivos da conduta do paciente, os efeitos que esta lhe promove, tais como angústia, raiva, culpa, impotência [...]. O interconsultor pode ajudar o médico a reconhecer a riqueza e a utilidade das respostas emocionais, tanto em si mesmo quanto em seu paciente, e instrumentá-las com êxito a fim de evitar a emergência de situações de conflito [...]. Por meio dessa e de outras intervenções, o interconsultor, em uma ou sucessivas interconsultas, ajuda o médico a restabelecer a confiança em sua própria ação e promove, assim, a manutenção essencial de sua autoestima.³

A presença do interconsultor, por si só, já pode funcionar terapeuticamente, aliviando a tensão do médico e da equipe assistencial como um todo. O interconsultor traz, para a equipe assistencial, a esperança de que algo será feito. Declara-se, então, uma espécie de “moratória institucional”, a partir da qual todos se debruçam sobre determinada situação clínica. Enquanto isso, o interconsultor procurará delimitar os principais fatores que interferem nessa situação, ouvirá atentamente aqueles que dela participam, devendo resistir às pressões para que resolva rápida e magicamente o problema.

O CONTEXTO INSTITUCIONAL

No espaço institucional, a assistência aos enfermos não se esgota no colóquio íntimo entre médico e paciente. As dificuldades relativas ao funcionamento institucional, como o excesso de demanda, a demora nas filas de espera para o atendimento, a falta de recursos para diagnóstico e tratamento e o pouco tempo para dedicar ao paciente, são comumente lembradas entre os principais obstáculos na relação com os pacientes. São problemas que exercem um grande impacto nos profissionais que trabalham na instituição e nas pessoas que buscam atendimento.¹⁷ Emaranham-se a uma estrutura que parece jogar uns contra os outros:

Tento às vezes manter algum diálogo, mas a gente tem que atender super-rápido. Fica difícil tirá-lo do *box* pra aprofundar [...].

É engraçado, um paciente contou pro interno que estavam enrolando ele desde o começo do ano, até que ele resolveu escrever uma carta pro Presidente da República, que respondeu, e, depois disso, nós o chamamos. Então, ele concluiu que nós o chamamos por uma pressão superior! É paciente terminal, deixa ele ficar pensando nisso... Por outro lado [...] E esse foi um caso de raio X de tórax! E a gente também não tem vaga, manda pra casa, perde o contato [...] Outro ponto é que os retornos são muito espaçados. Essa estrutura joga você contra o paciente, e vice-versa.

Vale lembrar que, em nosso país, a maioria dos serviços de interconsulta encontra-se em instituições de ensino. O hospital universitário é uma organização complexa, com um rol ampliado de objetivos, que procura conciliar necessidades de assistência, de pesquisa e de ensino. Diversas soluções vão sendo empreendidas, como rodízios de alunos e residentes, criação de serviços de triagem, ambulatórios especializados, equipes multidisciplinares, rotinas de atendimento, diferentes ocupações do espaço, etc. Há também os interesses específicos dos diversos grupos profissionais que circulam na instituição, uma instituição que gera suas próprias urgências, frequentemente colocadas acima das outras.

Médicos jovens, os residentes ficam na linha de frente da instituição, e seus depoimentos revelam preocupações com problemas institucionais que são vistos como entraves a sua formação e ao relacionamento com os pacientes. Sentem que não devem ser responsabilizados por erros advindos de normas institucionais ou de orientações com as quais não concordam. Veja, por exemplo, o depoimento desse médico-residente:

Instalei a diálise nela. Decidi hoje, eu! Não ia deixar ela ir sozinha. No meu plantão ela não vai morrer. A ordem do chefe da enfermaria era pra não fazer nada. Só que cheguei lá hoje, e a mulher completamente “zoró” [...]. O plantão é meu, assumi e acabou. Se ela morrer, pelo menos com peso na consciência eu não vou ficar.

Podemos observar, notadamente entre médicos recém-formados e internos de medicina, como os aspectos conflituosos da instituição podem não ser decodificados, confundindo-se com os sentimentos dos que aí atuam. Com uma assistência emperrada, a prática institucional, às vezes, dá um retorno pouco satisfatório a quem necessita ir ganhando confiança em sua capacidade profissional. Problemas institucionais acabam reforçando a insegurança e o sentimento de frustração profissional. Sente-se receber menos do que se dá, e o descontentamento gerado por essa situação é transmitido e compartilhado com a população assistida.

Entretanto, a instituição proporciona certa estabilidade aos profissionais que nela trabalham, reassegura a aprendizagem e comumente permite a criatividade. Há outras compensações, pela

participação em pesquisas, pela experiência administrativa, pelas publicações científicas, pelos títulos, etc. Em seu trabalho, os profissionais tornam-se impregnados por esses aspectos gratificantes da instituição, como se evidencia na seguinte fala:

Geralmente já passaram por vários médicos e, apesar disso, eles vêm mal informados. Causa certa ansiedade. Chegam desconfiados e convencidos de que não vão ser bem atendidos outra vez, apesar de que nós, desta instituição, já temos uma tradição de dar tratamento um pouco mais personalizado. É paradoxal isso, mas eu sinto que eles têm mais confiança aqui do que fora [...].

Tenho a impressão de que aqui nesta instituição dá pra criar vínculo. Apesar de ser um volume [de atendimento] muito grande, a gente acaba tendo um vínculo maior com o paciente. O vínculo é até maior aqui, eles acabam respeitando mais a gente aqui.

O encaminhamento por falta de tempo

Comumente referido como uma limitação imposta pela instituição, o pouco tempo destinado a cada consulta esconde outra faceta: evita-se, assim, lidar com os aspectos psicossociais que surgem no contato com o paciente. O surgimento desses aspectos na entrevista pode mobilizar o médico, o que é visto como um empecilho para o raciocínio clínico. O médico pode colocar-se em uma posição defensiva, o que impede a compreensão do que está ocorrendo no encontro com o paciente. Dar pouco tempo e logo encaminhar o paciente ao psiquiatra, ainda que as pressões institucionais também justifiquem essa atitude, é uma maneira de se proteger contra a invasão do emocional na tarefa assistencial, como pode ser visto no seguinte relato:

A gente se dedica um pouco menos do que deveria. Quando você está disposto, está trabalhando, vai bem. Agora, no dia em que está cansado, deu dois plantões, aí te incomoda um pouco, você foge um pouco. Sabendo em que quarto ele está, você passa mais rápido por ali [...].

Aqui na universidade é muito difícil de se ter um papo, pois você chega lá na frente e tem 15 pacientes pra ver num tempo de quatro horas. Mas vejo problemas psicossomáticos no consultório, isso é muito comum. O paciente às vezes vem ao médico porque ele tem necessidade de contar um problema, não tem nada orgânico.

Outro comportamento observado diante dessa pressão em relação ao tempo reduzido é adiar o aprofundamento nas condições emocionais do paciente para a próxima consulta. Uma próxima consulta que, tendo em vista a eficiência dos esquemas de rodízio do hospital-escola, nunca será com o mesmo médico. Tal prática impede a vinculação do profissional com o paciente. A questão “para que aprofundar se sinto medo de fazer isso e não saber o que fazer depois?” muda para algo mais fácil de ser aceito, como “para que aprofundar se, quando esse paciente retornar à consulta, não serei eu quem irá atendê-lo?”. A fala a seguir fornece um exemplo:

A gente até percebe, mas falta tempo pra aprofundar na questão. E outra falha grave nossa: a gente não se aprofunda porque não sabe o que fazer, não tem preparo, não tem respostas. Na área da sexualidade, a gente fala: “Olha, na próxima consulta [...]” ou “a senhora conversa com seu marido e [...]”. A gente não tem preparo nenhum pra lidar com isso, a gente foge na hora. O máximo é fazer um esclarecimento, uma orientação ridícula que qualquer revista faria igual [...]. Não vale nada, não é o que ela tá querendo. No próximo retorno não a atenderei mais, ou o que falamos não anoto e não lembro.

São exemplos que falam por si. O rodízio, notadamente nos estágios de curta duração, impossibilita o estabelecimento de um vínculo. Tanto o médico quanto o paciente defendem-se

da perspectiva de separação, abstendo-se de investir em um relacionamento que já tem data marcada para acabar.

Serviços de triagem e de superespecialização

O hospital geral universitário é uma instituição onde grande parte da assistência funciona em serviços superespecializados. Nesses serviços, geralmente encontramos critérios de seleção de pacientes bastante estritos. O surgimento de um ou vários esquemas de triagem passa a ser uma consequência disso. Alguns pacientes não podem ser acolhidos por falta de “capacidade resolutive quantitativa”, ou seja, pela alta demanda de pessoas que afluem ao serviço. Outros, por falta de “capacidade resolutive qualitativa”, que depende da disponibilidade de recursos humanos, recursos de apoio diagnóstico e de tratamento.

O ambulatório superespecializado, por sua vez, pode se estruturar sob regras rígidas de funcionamento, privilegiando normas e papéis a serem cumpridos. O aprimoramento do conhecimento científico passa a ser, muitas vezes, a finalidade prioritária do serviço, e o paciente é transformado em um agente intermediador do ensino e das pesquisas em desenvolvimento:

Aqui a gente quase que encaminha sempre [...]. São automaticamente encaminhados. E, discutindo com o docente: “Encaminha pra psiquiatria, não dá tempo, não é nosso assunto aqui dentro [...]”.

Na prática, o que temos observado é que o término da exploração diagnóstica, a resposta desfavorável ao tratamento ou mesmo o término de uma pesquisa deixam de garantir ao paciente o lugar que ele ocupava na instituição anteriormente. Outra possibilidade é, no caso de ele trazer queixas que “fujam do objetivo” do ambulatório, receber um rótulo de transtorno emocional e ser encaminhado ao psiquiatra. Não deixa de ser um paciente “recusado”, que ficaria circulando em diversos serviços do hospital, sujeito a inúmeros encaminhamentos. Encaminhar ao psiquiatra faz parte de uma rotina praticada compulsivamente na assistência institucional. Talvez guarde-se a esperança de que um atendimento personalizado possa pôr fim ao movimento errante que certos pacientes são condenados a fazer dentro da instituição superespecializada.

Encaminhamentos e ritmo institucional

Término de estágios, fins de semana, vésperas de feriado, férias escolares e altas hospitalares são algumas das chamadas “crises de contato” por que passam alunos, médicos e pacientes.¹⁸ É notória a frequência com que se solicita, muitas vezes em caráter de urgência, a presença de um psiquiatra poucas horas antes da alta de pacientes que estão internados há vários dias.

Comumente, ao chegarmos à enfermaria, o interno ou o residente que solicitou tal presença já não se encontra estagiando naquela enfermaria. Ou, então, ao chegarmos à enfermaria ainda na mesma manhã do pedido, o paciente já foi embora, e o médico solicitante mostra-se pesaroso pela nossa demora.¹⁹ É possível que, em situações como essas, o término do estágio em um ambulatório ou em uma enfermaria revele ao interno ou ao médico residente o caráter técnico e impessoal que marcou a intervenção junto ao paciente.

A alta hospitalar obriga o médico a introjetar suas próprias ansiedades hipocondríacas projetadas no paciente, que, por se encontrar regredido, as aceitou em troca de segurança.²⁰ O psiquiatra seria chamado para assumir o “lado psicológico” de um paciente prestes a ser “abandonado” pelo seu médico, em uma das crises de contato a que nos referimos. Encaminhamentos ao psiquiatra acompanham esse ritmo institucional, tentando, assim, reparar o abandono que os médicos sentem que impõem periodicamente aos seus pacientes.

Encaminhamentos impessoais

É comum questionarmos se, para dado paciente, seria melhor encaminhá-lo para tal ou qual colega da especialidade. Geralmente, escolhemos especialistas a quem respeitamos profissionalmente e cujos traços de personalidade são adequados às características observadas nos pacientes. Ao chegar um paciente novo para consulta, sempre lhe é perguntado quem o encaminhou. Fazendo a pergunta ao paciente, ou pelo que ele nos fala, procuramos nos inteirar do que o colega comentara sobre nossa pessoa e nosso trabalho, como o paciente vê o encaminhamento, etc. Todas essas condições formam um jogo de identificações essencial para que médicos e pacientes se reconheçam como pessoas e como profissionais.

No contexto institucional, os encaminhamentos não são feitos de pessoa para pessoa. É comum que o paciente encaminhado desconheça o médico que o atendeu e não se refira a ele pelo nome. O médico também pode não se lembrar do paciente nem da razão que motivou o encaminhamento. Assim, na impessoalidade dos encaminhamentos, perde-se todo um jogo de identificações e incentivos para o desenvolvimento de vínculos. Além disso, perde-se a busca de encaixes entre profissionais e pacientes que ocorre mais facilmente em situações em que as pessoas têm nome e personalidade.

Encaminha-se para profissionais que cumprem papéis e dos quais se esperam determinadas atitudes. Esse caráter impessoal do encaminhamento reforça a *cumplicidade no anonimato* existente entre os membros da instituição (incluindo-se, com frequência, o próprio paciente), a partir da qual ninguém se responsabiliza pelas ações que se praticam ou que deixam de ser praticadas. Essa noção foi desenvolvida por Michael Balint, psiquiatra e psicanalista, cuja obra pode ser considerada a essência da psicologia médica.⁷

Os encaminhamentos impessoais que observamos no ambiente institucional parecem reforçar esse caráter de cumplicidade e de defesa em um espaço fusional e mudo – uma ideia que vem ao encontro do pensamento de Jaques²¹ e Bleger:²⁰ muitos encaminhamentos ao psiquiatra dão-se para manter as defesas contra a ansiedade da equipe assistencial e para manter a funcionalidade de um pacto institucional de natureza simbiótica. Esse pacto nasceria de uma situação irreflexiva que procura gratificar aspectos silenciados de cada um de seus integrantes (conflitos, expectativas, histórias pessoais, objetivos e normas institucionais).

Encaminhamentos e relações grupais

Ao entrar em uma enfermaria, o psiquiatra torna-se um observador participante de toda a dinâmica de relações humanas e mecanismos psicológicos subjacentes ao funcionamento grupal. Orientado pelos dados que obtém por meio de uma entrevista ampliada (com pacientes, familiares, médicos, enfermeiros) e por sua intuição, o psiquiatra poderá captar vários aspectos aí presentes, entre os quais o grau de coesão grupal, os conflitos atuantes (como problemas de ciúme e rivalidade), a hierarquia entre os elementos da equipe e o papel dado a cada um de seus integrantes.¹⁸

São comuns as solicitações para que o psiquiatra assuma diversos papéis em uma equipe em que há alto grau de dissociação entre seus profissionais – cada um desincumbe-se do tratamento de uma parte do paciente. Há um problema social que, muitas vezes, é a razão do encaminhamento, e a disponibilidade da assistência social não foi lembrada. O paciente está solicitando demais, quer alguém para conversar, e não foi percebida a boa relação que um auxiliar de enfermagem conseguiria estabelecer com ele, acalmando-o.

O psiquiatra pode ser chamado para ajudar a integrar as partes do paciente que estão cindidas sob os cuidados de uma equipe igualmente cindida, que quer se reestruturar. No entanto, também pode ser convidado a se manter isolado, participando da dissociação e das defesas do grupo, assumindo apenas o “lado psicológico” do paciente.

Outro aspecto comumente observado em uma enfermaria é que a equipe assistencial se move segundo determinadas regras, algumas claramente estabelecidas, outras implicitamente presentes na atuação de seus profissionais. Esse funcionamento está marcado por um caráter hierárquico que busca adequar cada um e sua ação a uma função predeterminada. O chefe da enfermaria, como líder do serviço, transforma-se no porta-voz das resistências do grupo, definindo se o trabalho de um profissional de saúde mental será ou não bem recebido:

Às vezes fico pensando se seria bom mandar esse paciente para a psiquiatria... Mas fico com receio, e a posição dos docentes também não altera muito, não [...].

[...] mas encaminhei mais por orientação do docente, tanto que não me lembro [do último encaminhamento à psiquiatria] [...].

Os internos e os novos residentes que estão de passagem pela enfermaria ligam-se aos pacientes e, comumente, são o que emerge dos conflitos vivenciados silenciosamente pelos integrantes da equipe. É comum, então, que seja um interno a deixar “escapar” um diagnóstico mantido em segredo para o paciente, é ele quem pressiona por uma licença de fim de semana e quem lembra o médico de que existem psiquiatras no hospital:

Agora a gente tem facilidades, né... O interno que me falou: “Por que você não chama a psiquiatria?”. Eu não tinha pensado, num plantão, chamar a psiquiatria [...] foi bem interessante [...].

Certa vez, uma médica-residente que cuidava de pacientes oncológicos pediu-nos uma interconsulta para uma paciente. Na verdade, ela – a médica-residente – não sabia mais o que fazer, pois cada dia era um docente diferente que visitava a enfermaria e orientava uma conduta distinta (outro exemplo de esquema de rodízio). Um dos docentes recomendava o seguinte: “Vamos fazer um tamponamento para conter a hemorragia”. Vinte e quatro horas depois, ela ouvia de outro docente: “Se começar a sangrar de novo, não vamos fazer mais nada, vamos

deixar ela morrer em paz”. A residente, angustiada, sentia que a decisão sobre a vida ou a morte da paciente estava em suas mãos, ao seguir a orientação de um ou de outro docente; então, resolveu pedir uma interconsulta urgente à psiquiatria.

Assim, encaminhamentos ao psiquiatra, que podem ser observados mais em pedidos de interconsultas vindos de certas enfermarias, representam tentativas de oposição a certas pressões de caráter hierárquico. Eles revelam, além disso, a inadequação do solicitante a um pacto que, em geral, se estabelece entre paciente, equipe assistencial e instituição. A solicitação de uma interconsulta psiquiátrica pode significar que a funcionalidade desse pacto entrou em colapso, porque alguém se sentiu frustrado em sua expectativa de gratificação.

REFERÊNCIAS

1. Botega NJ. No hospital geral: lidando com o psíquico, encaminhando ao psiquiatra [tese]. Campinas: Universidade Estadual de Campinas; 1989.
2. Kiev A. Magic, faith, and healing. New York: Free Press of Glencoe; 1971.
3. Ferrari H, Luchina N, Luchina IL. La interconsulta médicopsicológica en el marco hospitalario. Buenos Aires: Nueva Visión; 1977.
4. Ferrari H, Luchina N, Luchina IL. Asistencia institucional: nuevos desarrollos de la interconsulta médico-psicológica. Buenos Aires: Nueva Visión; 1979.
5. Costa JSFB. Organização de instituições para uma psiquiatria comunitária. II Congresso da Associação de Psiquiatria e Psicologia da Infância e Adolescência. Rio de Janeiro; 1976.
6. Mendel G. Articulações críticoproductivas entre intervenção individual, grupal e institucional. In: Baremlit GF. O inconsciente institucional. Petrópolis: Vozes; 1984.
7. Balint M. The doctor, his patient, and the illness. New York: Int. Universities; 1973.
8. Botega NJ, Cassorla RMS. Encaminhamento ao psiquiatra e relação médicopaciente: uma análise qualitativa dentro de um referencial psicodinâmico. Rev ABPAPAL. 1991;13(2):53-8.
9. Knobel M. La relación entre el médico y el psicoterapeuta en el tratamiento de la enfermedad somática. Acta Psiquiatr Psicol Am Lat. 1986;32:31-40.
10. Mendelson M, Meyer E. Countertransference problems of the liaison psychiatrist. Psychosom Med. 1961;23:115-22.
11. Botega NJ. A palavra do médico e seus sentidos: um estudo qualitativo de alguns termos psiquiátricos utilizados na prática médica. Rev ABPAPAL. 1992;14(1):33-8.
12. Raimbault G. El psicoanálisis y las fronteras de la medicina. Barcelona: Ariel; 1985.
13. Sarano J. O relacionamento com o doente: dificuldades e perspectivas no relacionamento entre terapeutas e clientes. São Paulo: EPU; 1978.
14. Schwab JJ, Brown J. Uses and abuses of psychiatric consultation. JAMA. 1968;205(2):65-8.
15. Botega NJ, Metze K, Marques EHF, Cruvinel A, Moraes ZV, Augusto L, et al. Attitudes of medical students to necropsy. J Clin Pathol. 1997;50(1):64-6.
16. Bourne S. Second opinion: a study of medical referrals in a seminar for general practitioners at the Tavistock Clinic, London. J R Coll Gen Pract. 1976;26(168):487-95.
17. Botega NJ. Encaminhamento ao psiquiatra e funcionamento institucional. Rev ABPAPAL. 1991;13(1):27-31.
18. Mello Filho J. Conceção psicossomática: visão atual. Rio de Janeiro: Tempo Brasileiro; 1983.
19. Magdaleno Júnior R, Botega NJ. IPC no hospital geral universitário. J Bras Psiq. 1991;40:95-8.
20. Bleger J. Temas de psicologia: entrevista e grupos. São Paulo: Martins Fontes; 1980.

21. Jaques E. Os sistemas sociais como defesa contra a ansiedade persecutória e depressiva. In: Klein M, Heimann P, Money-Kyrle RE. Temas de psicanálise aplicada. Rio de Janeiro: Zahar; 1969.



Interconsulta psiquiátrica: aspectos da técnica

Neury José Botega

Clarissa de Rosalmeida Dantas

Uma característica básica e fundamental da interconsulta psiquiátrica é a natureza aguda e dinâmica dos problemas surgidos no hospital geral. O desafio da formulação diagnóstica e do tratamento é considerável, principalmente se levarmos em conta a gravidade de muitos quadros clínicos, a costumeira escassez de informações e a rapidez esperada em nossa atuação. Além dos aspectos concernentes ao paciente, frequentemente o psiquiatra lida com os condicionantes psicológicos e institucionais que modulam a relação entre os membros da equipe assistencial e desta com o paciente. Os aspectos técnicos da interconsulta, relativamente pouco difundidos em nosso meio, são essenciais para o sucesso da intervenção. Este capítulo trata do *modus operandi* da interconsulta, aborda suas etapas e aponta, em cada uma delas, os aspectos técnicos envolvidos.

Apesar das distinções entre modelos institucionais e das controvérsias conceituais que permeiam sua prática, os objetivos gerais da interconsulta psiquiátrica são: prover tratamento específico a pacientes acometidos por transtornos mentais, atendidos em serviços não psiquiátricos; modificar a estrutura assistencial centrada na doença para uma forma de trabalho centrada no paciente; valorizar o papel da relação médico-paciente; e aprofundar o estudo da situação do doente e dos profissionais nas instituições médicas, bem como aproximar a psiquiatria de outras especialidades médicas e profissões da área da saúde.

A interconsulta deve ser atendida com presteza, tendo o seu motivo esclarecido diretamente com o médico assistente. A entrevista de avaliação precisa ser ampliada para membros da equipe assistencial, familiares e, às vezes, colegas de quarto, e os exames físico e psíquico devem ser cuidadosamente realizados. A capacidade de elaborar um diagnóstico situacional, a flexibilidade e o pragmatismo de suas ações, bem como a boa interlocução com os pacientes e a equipe assistencial são qualidades esperadas de um interconsultor. Em cada interconsulta, há o desafio de se responder às várias perguntas reunidas no Quadro 8.1.

QUADRO 8.1

Algumas questões que o interconsultor deve considerar

Coleta inicial de informações

- O que motivou a solicitação de interconsulta?
- Qual é a expectativa da equipe assistencial?
- Há informações consistentes sobre o comportamento do paciente?

Após ter examinado o paciente

- As condições do paciente e do ambiente permitiram uma boa avaliação?
- O exame psíquico foi feito cuidadosamente?
- Seria útil aplicar algum instrumento de avaliação padronizado?
- O exame físico foi realizado a contento?
- A avaliação neurológica permite excluir uma síndrome orgânica cerebral?
- Quais exames complementares são necessários?

Formulação diagnóstica

- O paciente tem um transtorno mental?
- Em caso afirmativo, qual a provável etiologia?
- Como o paciente reage à doença e à hospitalização?

- Ele tem esperança, deseja viver?
- Com quem ele pode contar para ajudá-lo?
- Há dificuldades na relação do médico (equipe assistencial) com o paciente?
- Há problemas institucionais agudos que estejam afetando os cuidados dedicados ao paciente?

Manejo

- O que de mais urgente precisa ser feito?
- Como reduzir o impacto de fatores estressantes?
- Como ajudar o paciente a enfrentá-los?
- Qual o tratamento adequado para o transtorno mental especificado?
- Qual medicamento é o mais indicado nesta condição clínica?
- Há risco de auto ou heteroagressão?
- O paciente pode ser considerado capaz para aceitar ou recusar um tratamento?
- Quanto à continuidade do tratamento: qual, em que local, por meio de quem?

Uma interconsulta não produz bons resultados quando o psiquiatra falha em um ou nos três seguintes pontos:

- indiferença ou ignorância a respeito da doença orgânica do paciente e de seu tratamento
- adoção de técnicas de manejo mais apropriadas a pacientes não hospitalizados
- má interlocução com a equipe assistencial nas etapas de coleta de informações e de planejamento terapêutico

Uma interconsulta produz melhores resultados quando ela é desencadeada por uma postura pró-ativa da equipe de interconsulta, que, a partir de triagem, detecta os pacientes que podem se beneficiar de uma intervenção, como ocorre, por exemplo, em casos de depressão, tabagismo e dependência de álcool.^{1,2} A detecção de casos ou situações de risco pode se dar, também, quando o profissional de saúde mental encontra-se inserido na equipe clínica ou cirúrgica e participa das visitas e discussões clínicas. Essas ações que se dão antes mesmo de uma solicitação de interconsulta chegar a nossas mãos diminuem o tempo de internação e os custos hospitalares.³

ETAPAS DA INTERCONSULTA

A interconsulta psiquiátrica para pacientes internados pode ser dividida em etapas, discriminadas nos subtítulos seguintes.

O pedido de interconsulta

A seguir, encontra-se a transcrição literal de alguns pedidos de interconsulta que selecionamos. Esse pequeno conjunto dá ideia do tipo de conhecimento e da flexibilidade exigidos do interconsultor. É importante ressaltar como a redação de cada solicitação, de alguma forma, sugere um cenário no qual a interconsulta é desenrolada, colocando-nos, em maior ou menor grau, de prontidão para a tarefa assistencial:

- Poliqueixoso, ansiedade muito grande. Solicito atendimento breve.
- Paciente com incoordenação de ideias e visível déficit mental. Peço avaliação. (Obs.: paciente parece pressionada a dar a criança logo ao nascimento.) Solicito esclarecimento diagnóstico para decidirmos se tem indicação de seguir no alto risco ou mesmo laquear a paciente.
- Paciente com insuficiência arterial periférica, com membro inferior direito amputado há dois anos. Inúmeras cirurgias de revascularização para membro inferior esquerdo. Operado de trombose mesentérica há 3 anos. Paciente atualmente perdendo a perna esquerda. Mesmo assim, não consegue parar de fumar. Solicito avaliação e conduta em vista da necessidade de parar de fumar, por terem sido esgotadas as possibilidades terapêuticas. Obrigado.
- Tentativa de suicídio com tiro no ouvido direito. Paciente encontra-se traqueostomizado, com pneumonia e mastoidite.
- Ansiedade + obesidade extrema + problemas de relacionamento familiar + incredibilidade religiosa. Receberá alta amanhã.
- Paciente submetido a transplante renal há 3 meses. Após o transplante, apresentando alterações do humor, com períodos de choro e de profunda irritabilidade. Em uso de corticoide.
- Paciente internada por diversas vezes por abscessos de repetição. Investigação imunológica normal. Chegou-se a suspeitar de que alguns abscessos eram por ela produzidos (autoinoculação, já teve mais ou menos 20 *intracatches* que “saíram”). Solicito avaliação do caso.
- Paciente com câncer de mama avançado, com metástases no pulmão e no fígado, em mau estado geral, com muita dor. Paciente em estado terminal.
- Paciente fez tentativa de suicídio, há 15 anos, ingerindo ácido muriático e desenvolveu estenose cáustica do esôfago. Tem indicação cirúrgica, mas solicitamos prognóstico quanto a novas tentativas de suicídio.

Há um caráter de urgência nos encaminhamentos ao psiquiatra. O médico espera e tem direito a uma pronta resposta do interconsultor. Esse caráter nem sempre está relacionado às condições clínicas do paciente, podendo corresponder a um ritmo institucional e a um sentimento subjetivo do médico.

Quanto antes a interconsulta for solicitada e realizada, maior sua eficiência, pois há menor tempo de internação, poupança de recursos econômicos e satisfação de pacientes, familiares e equipe assistencial.^{3,4} Se o psiquiatra não puder atender prontamente ou não for capaz de tomar

as primeiras providências no mesmo dia da solicitação de interconsulta, deve entrar em contato com o médico assistente, a fim de estabelecer há necessidade de medidas preliminares.

A solicitação de interconsulta deve partir do médico responsável pelo paciente ou, se não for esse o caso, contar com sua anuência. Se a solicitação vier do paciente, de um médico que estava de plantão ou de outro membro da equipe assistencial, o psiquiatra procederá à avaliação apenas se contar com a concordância do médico assistente, que, afinal, tem a responsabilidade primária por tudo o que acontece ou deixa de acontecer com o paciente. O psiquiatra pode imaginar como se sentiria se um paciente seu fosse avaliado em interconsulta por outro médico do hospital, sem que isso contasse com sua autorização.

A solicitação de interconsulta deve vir redigida em um impresso destinado para tal fim, mas a falta deste não deveria servir, ao interconsultor, como escusa para postergar a avaliação do paciente. São frequentes os pedidos informais para novas avaliações, como “já que você está aqui mesmo...”. Essas solicitações feitas rapidamente no corredor referem-se a pacientes ou a situações clínicas que requerem avaliação formal e cuidadosa.

Peculiaridades na redação do pedido de interconsulta estimulam as primeiras hipóteses sobre a situação clínica que será objeto de avaliação. Mesmo os pedidos sumários e impessoais já provocam algum tipo de reação e ansiedade antecipatória no psiquiatra. O raciocínio clínico inicia-se aí. Exemplos de pedidos lacônicos são: “paciente receberá alta amanhã. Solicito avaliação e conduta” – já sugerindo várias hipóteses a serem testadas: pressões de demanda?, pressões hierárquicas?, atendimento cindido?, médico atarefado?, culpado?, mudança de médico responsável?, há um transtorno mental que demandará acompanhamento ambulatorial?

Raramente, os pedidos vêm redigidos em primeira pessoa, embora, com frequência, a pessoa do médico e a qualidade da relação dos membros da equipe assistencial, entre si e com o paciente, encontrem-se entre os aspectos que o interconsultor sempre deve levar em conta. Há casos em que mais do que uma solicitação de interconsulta para o mesmo paciente chega quase simultaneamente em nossas mãos. Às vezes, mais do que um profissional da equipe assistencial contribuiu para a redação do pedido de interconsulta. Confirmava-se, posteriormente, a intensa angústia compartilhada pelos membros da equipe em relação a determinada situação clínica.

Fala-se de um conteúdo manifesto e de um conteúdo latente (ou mais profundo e, de início, não aparente) nos pedidos de interconsulta. Frequentemente, solicitações redigidas de forma muito técnica, ou mesmo lacônica, escondem aspectos que modulam fortemente a relação médico-paciente e que, também, podem estar motivando, secretamente, o pedido de ajuda. Um médico pode, por exemplo, solicitar “avaliação de conduta”, sem deixar claro que, na realidade, está muito contrariado e que gostaria de dar alta para um paciente de difícil manejo, mas que ainda inspira cuidados. Se o psiquiatra não se der conta disso, o paciente poderá receber alta, pelo fato de seu médico interpretar o silêncio do psiquiatra como consentimento.

Desaconselhamos, no entanto, uma postura adotada de forma estereotipada, que sempre põe o psiquiatra a investigar o que está por trás de um pedido de interconsulta. Agindo assim, pode-se deixar em segundo plano o paciente que sofre concretamente uma dor, bem diante de nossos olhos. Dizemos isso com o intuito de coibir, em nossa tarefa, interpretações psicodinâmicas rebuscadas e onipotentes, que só vêm a prejudicar as partes envolvidas. Quando um sentido

latente é forte motivador do pedido de interconsulta, ele se revela no decorrer do processo de avaliação, cuidadosamente empreendido pelo psiquiatra.

Contato prévio com o médico assistente

O contato prévio com o profissional que solicitou a interconsulta visa cumprir várias necessidades, entre elas apresentar-se como o psiquiatra que avaliará o paciente, esclarecer o motivo da solicitação de interconsulta e se inteirar a respeito da história e da situação clínica do paciente. É o momento de esclarecer a razão da solicitação de interconsulta, e duas questões devem ser mantidas em mente: por que a interconsulta foi solicitada e o que se espera do psiquiatra interconsultor. Essas questões geralmente não são explicitadas. Tanto o médico quanto o paciente terão maior chance de ser atendidos em suas necessidades se o interconsultor puder ser preciso quanto ao tipo de ajuda que cada um espera receber. Algumas dessas informações são obtidas antes mesmo de ver o paciente. Outras, naturalmente, vão-se agregando com o desenrolar do atendimento. Todos esses dados contribuirão, mais tarde, para a formulação de um diagnóstico situacional.

É recomendável esclarecer o que se quis dizer com termos valorativos (p. ex., “paciente manipulador”) ou técnicos (p. ex., “ideias delirantes”). Estes últimos podem ter sido empregados com sentido diferente daquele inicialmente entendido pelo psiquiatra.

É importante averiguar se o paciente já sabe que será avaliado por um psiquiatra, como ele reagiu a essa comunicação ou se o médico assistente “esqueceu-se” de falar sobre isso. O paciente deveria ter a chance de discutir sua situação com seu médico e ouvir deste a justificativa para a interconsulta. Desde que não haja riscos para si ou para outros, um paciente poderá, afinal, recusar-se a ser avaliado por um psiquiatra.

Em suma, o interconsultor deve inteirar-se da atitude básica do médico em relação ao paciente. Se, didaticamente, essa atitude for colocada ao longo de um *continuum*, poderemos observar que ela costuma variar de uma distância profissional ótima até uma postura extremada, tendendo a um dos dois polos: demasiada proximidade (quando o médico se identifica e “se mistura” com o paciente) ou demasiado distanciamento (levando à rejeição ou à evitação). Quanto mais o médico se afastar a uma distância ótima em relação ao paciente, maior será a chance de não fazer um diagnóstico correto, seja de patologia orgânica (quando teme ou rejeita o comportamento do paciente), seja de um transtorno psiquiátrico (quando se identifica com o paciente, desejando resgatá-lo de seu sofrimento emocional e protegê-lo do psiquiatra).

Entrevista ampliada

Há necessidade de uma entrevista ampliada, na qual se incluem, além do médico assistente, outros membros da equipe assistencial e familiares do paciente.

É de suma importância informar-se com a enfermagem. Em geral, falta aos médicos o tempo para observar mais detalhadamente o comportamento de seus pacientes. Membros da equipe de enfermagem e um assistente social ou fisioterapeuta convivem mais com o paciente e podem

fornecer informações valiosas e, para tanto, precisam ser encorajados, superando receio ou vergonha de expressarem suas observações e opiniões. Comumente, a enfermagem observa como o paciente se prepara e reage ao receber visitas, e tais informações são bastante úteis no contexto da avaliação psiquiátrica.

Às vezes, a pessoa que ocupa o leito do lado também acrescenta observações preciosas, como, por exemplo, se o paciente se mantém estável no decorrer do dia, se piora e fica confuso ao anoitecer, etc. Além de aspectos objetivos como esses, valorizam-se os depoimentos, os sinais e a intuição clínica, que, em conjunto, são capazes de revelar angústias pessoais, estados de ânimo, dificuldades na equipe assistencial e bloqueios na comunicação.

A entrevista ampliada não supera, mas relativiza, a dificuldade do interconsultor em iniciar seu trabalho em um contexto de carência de informações. Em situações especiais, a ausência de dados sobre a biografia do paciente poderá dar vida a boatos e a suposições (“eu-acho-quês”). A comunidade do hospital encarrega-se de preencher lacunas a respeito da vida pessoal de algumas pessoas aí internadas, às vezes, com indisfarçável prazer. De modo geral, sempre que houver várias versões sobre algum fato, o psiquiatra terá de exercer ao máximo sua capacidade de se informar, discriminar e agir pragmaticamente.

Leitura atenta do prontuário

A leitura atenta do prontuário, com as anotações do médico e da enfermagem, faz parte dessa fase inicial da interconsulta. Poderá haver, nas anotações da enfermagem aí arquivadas, bons registros sobre o comportamento e o estado emocional do paciente. É preciso inteirar-se dos fatos (história da moléstia, evolução, exames laboratoriais) com o mesmo espírito com que um cirurgião examina o paciente tido pelo clínico como acometido por apendicite. Assim, examina-se novamente e repete-se o raciocínio clínico. Todas as pistas que confirmem ou forneçam uma explicação alternativa para a hipótese inicial são importantes. Geralmente, há pouca informação sobre a história pessoal do paciente, portanto, será preciso convocar a família.

A técnica de inversão da abordagem

Antes mesmo de examinar o paciente, o psiquiatra contará com várias pistas, obtidas de várias fontes, que o levarão a algumas hipóteses a serem testadas. Além de inteirar-se do quadro do paciente, o interconsultor deve estar ciente das estratégias de manejo até então adotadas pela equipe assistencial para a situação clínica, considerando fatores psicológicos, bem como biológicos, que permitirão ao psiquiatra sugerir uma *inversão na abordagem*.⁵

Por exemplo, em uma situação clínica na qual causas orgânicas já foram excluídas e em que se espera que o psiquiatra encontre causas psicológicas para o problema do paciente, o interconsultor deve se perguntar:

O médico assistente empregou diligentemente seu método costumeiro de procurar uma doença orgânica, em consonância com os sinais e sintomas apresentados pelo paciente?

Não se trata de uma tentativa vaidosa de descobrir o que o colega clínico deixou de fazer ou diagnosticar. O que importa é manter a lembrança de que o médico assistente pode ter tido seu raciocínio clínico, bem como seu desempenho, obscurecidos pelo simples fato de ter encarado o paciente como “psiquiátrico”. No Capítulo 12, sobre pacientes mentais graves internados, são abordadas algumas das consequências dessa visão restrita e dicotômica (mente *versus* corpo), em que o paciente psiquiátrico é tratado como se não tivesse um corpo que também pode adoecer.

É interessante, aqui, lembrar outra regra que costuma ajudar o interconsultor a considerar o que alguns pacientes provocam na equipe assistencial, a *regra dos adjetivos*:

- paciente perturbado → perturbador
- paciente deprimido → deprimente
- paciente ansioso → ansiogênico
- paciente raivoso → enraivecedor

A partir da identificação do paciente como “psiquiátrico”, o médico pode deixar de observá-lo e examiná-lo, solicitar ou se inteirar dos últimos exames. Se o interconsultor detectar essa possibilidade, terá mais um motivo para examinar cuidadosamente o paciente. Assim, deverá inverter a abordagem baseada no “é psiquiátrico” para “pode se tratar de um distúrbio orgânico não diagnosticado”.

Ao se sentir incapaz de proceder a uma reavaliação clínica completa, o psiquiatra deve procurar rediscutir com o médico assistente as diversas possibilidades de diagnóstico que tem em mente, o que deverá reconduzir à procura de possíveis bases orgânicas que expliquem determinado quadro sintomatológico.

Outra pergunta importante que o interconsultor deve se fazer é: qual foi a abordagem psicológica que o médico assistente deu para o caso? Qualquer que tenha sido a abordagem psicológica adotada, ela não surtiu o esperado sucesso e, provavelmente, precisa ser mudada, e, para isso, foi chamada a psiquiatria. O interconsultor, valendo-se de uma abordagem alternativa, poderá sair-se melhor.

Avaliação do paciente

Neste capítulo, não abordamos questões específicas referentes à avaliação do paciente. Isso é feito no Capítulo 9, no qual enfatizamos dois temas principais: a técnica de entrevista tem nuances especiais, combina questões abertas e fechadas e focaliza a situação de crise; o exame do paciente deve ser completo (físico geral, neurológico, psíquico), com atenção especial para as funções cognitivas.

Diagnóstico situacional

Devemos levar em conta que a interconsulta aparece em uma situação especial, em um momento especial da evolução da enfermidade. Por conseguinte, o útil é diagnosticar e determinar essa “situação especial” e priorizar a área em que esta se

manifesta. Por isso, a equipe de interconsulta deve obter diagnósticos situacionais que permitam detectar pontos de urgência de um estado peculiar (“estar enfermo”) em um momento também peculiar (“estar internado”).⁶

Temos a expectativa a respeito de como agem e reagem pacientes, familiares e profissionais diante de certas situações. Igualmente temos a expectativa de como nós mesmos reagiremos. Variações dessa norma, nos outros ou em nós mesmos, precisam ser percebidas, observadas e compreendidas. Essa postura clínica amplia os recursos para o diagnóstico situacional e o manejo da situação clínica como um todo.

Na mesma linha de observação, comparação e ponderação daquilo que se distancia da norma, lembramos que o psiquiatra interconsultor entrará várias vezes, ao longo do tempo, na mesma enfermaria. Estará a par da filosofia do serviço, das hierarquias que aí se estabeleceram, das práticas adotadas, da postura esperada dos participantes da equipe assistencial, enfim, do clima emocional habitual e da cultura da enfermaria. A cada interconsulta realizada, a representação que ele tem a respeito de determinado serviço será reforçada ou distorcida. É preciso estar atento a mudanças nesse ambiente, bem como a situações de tensão institucional que possam interferir negativamente na situação clínica sob exame.

De modo mais amplo, um diagnóstico situacional deve abarcar várias dimensões, resumidas no Quadro 8.2.

QUADRO 8.2

As diversas dimensões do diagnóstico situacional

Motivo da interconsulta	Reações do paciente Problemas na relação médico-paciente Conflitos na equipe assistencial Problemas institucionais Crise no funcionamento da família
Condição clínica do paciente	Razão e tempo de internação Resposta ao tratamento Transtorno mental comórbido
Relação médico-paciente	Empatia Distanciamento afetivo Comunicação Confiança Colaboração recíproca
Impacto da doença e da hospitalização	O que representa o adoecimento Vida pessoal, social, profissional, etc. Características da personalidade Mecanismos de defesa e de enfrentamento (<i>coping</i>) Atitude e expectativa Adesão ao tratamento
Sistema de apoio social	Família, amigos Condições de moradia Trabalho Afiliações Plano de saúde Condições econômicas
Estressores psicossociais	Ambiente social, amizades Vida íntima Família, moradia, finanças Trabalho Problemas com a Justiça

O diagnóstico situacional exige a recodificação das informações, dando-lhes sentido em um todo coerente e significativo. Um diagnóstico como esse é capaz de ampliar a visão do interconsultor e, assim se espera, da equipe assistencial a respeito da recente situação de vida do paciente, de como ele vem lidando com a doença e a hospitalização e de como se encontram as relações estabelecidas entre o paciente e as pessoas a seu redor. O que pode afiançar a correção de um diagnóstico situacional (da mesma forma que de uma boa interpretação em psicoterapia) é a nova visão que ele abre para a compreensão de uma gama mais ampla de informações e comportamentos.⁷

Devolução da informação

Formulação é o que você pensa. Comunicação é o que você conta. Você deveria comunicar a parte de sua formulação que é relevante para o problema que está em sua mão, de modo a persuadir outros a adotarem seu plano de manejo. Comunicação é persuasão, e, para persuadir, você tem que ser claro e convincente com todos os que deverão colaborar no plano de manejo a ser implementado – médico e pacientes e, amiúde, enfermeiros, assistentes sociais, outros profissionais e familiares também.⁵

A comunicação é um dos pontos capitais do êxito ou do fracasso de uma interconsulta. Após ter avaliado o paciente, é aconselhável informar pessoalmente o médico assistente, e eventualmente, outros membros da equipe sobre a impressão diagnóstica e o tratamento proposto. Essa atitude demonstra o interesse do psiquiatra pela situação do paciente e pelas preocupações do colega que o chamou para a interconsulta, reforçando um espírito de confiança e de trabalho em conjunto.

A formulação diagnóstica e o plano de tratamento precisam ser traduzidos para uma linguagem clara, objetiva e concisa, sem jargões nem teorizações psicológicas. Espera-se do interconsultor uma relação simétrica, um trabalho em conjunto em uma situação concreta (considerações metapsicológicas devem ser proscritas). Em alguns casos, o interconsultor terá de trabalhar para persuadir as partes envolvidas a respeito dos riscos e os benefícios de adotarem ou não suas recomendações. Agindo assim, frequentemente encontrará um interlocutor interessado, que procurará compartilhar esforços terapêuticos.

Sugestões de exames complementares e de manejo, bem como de mudança no esquema terapêutico, devem ser discutidas com o médico assistente. Caso seja preciso mais alguma coisa, então é importante que se estabeleça prontamente quem o fará. Deve-se esclarecer sobre o seguimento do caso – se o paciente será acompanhado pelo psiquiatra ou não. As esferas de responsabilidade precisam ser claramente definidas, o que exige discussão com as partes envolvidas.

Embora, essencialmente, o interconsultor seja um “negociador”, há situações de impasse, felizmente raras, em que ele terá de se opor energicamente a uma postura ou conduta adotada pelo médico assistente. A exemplo disso está a contraindicação formal à alta hospitalar de um paciente com risco de suicídio, quando o chefe da enfermaria pressiona a liberação do leito, ou o atestado da plena capacidade de um paciente que recusa tratamento, de forma contrária à expectativa e à pressão da equipe assistencial.

Tal medida é tomada para proteger os direitos do paciente, e não para disputar poder. Esgotadas as possibilidades de “negociação” com o colega, a postura determinada do interconsultor geralmente inibirá o médico assistente mais impulsivo. Este último ficará temeroso das implicações legais, caso, tendo contrariado as recomendações da interconsulta, o pior venha a acontecer.

Manejo

Às vezes, a principal tarefa do interconsultor será a tentativa de alterar a maneira como o médico, ou a equipe assistencial como um todo, vem lidando com determinada situação. Imaginemos um paciente muito desconfiado, que se nega a se submeter a uma necessária cirurgia. O cirurgião responde com irritação e ameaças, o que reforça o comportamento do paciente. Qual caminho o psiquiatra deverá tomar como foco de sua ação? Sem usar termos psiquiátricos ou teorias rebuscadas, mostrará ao colega esse mecanismo de círculo vicioso e como a exasperação dos profissionais aumenta o medo e a resistência do paciente.

Imaginemos outra situação, na qual um paciente reaja à condição de doença aguda com muita passividade, sem demonstrar força para reagir, regredindo em seu comportamento e suas necessidades. Alguns membros da enfermagem passam a tratá-lo como criança (“vamos tomar o remedinho?”), “mas que feio com esse cabelinho todo despenteado!”). O interconsultor deverá reconhecer a dedicação carinhosa da enfermagem, mas acrescentar que o paciente tratado dessa forma poderá sentir que o julgamos frágil e que não adianta se esforçar como um adulto, pois ele não conseguirá.

Entre as abordagens que podem ser direcionadas à equipe assistencial como um todo, destacamos os grupos operativos. Esse tema é tratado no Capítulo 4, sobre pacientes-problema, referindo às minirreuniões de equipe. Aqui, a título de exemplo, descrevemos uma situação clínica em que foi possível empregar essa técnica de intervenção:

A solicitação de interconsulta veio assim redigida: “Paciente de 16 anos, com diabetes insulino-dependente e tumor hepático. Em fase terminal. Solicitamos avaliação e conduta”. Tratava-se de um jovem que havia passado por várias internações naquela enfermaria e que chamaremos de Carlinhos. Todos o queriam muito bem, e ele havia se transformado numa espécie de “filho” da equipe assistencial. Franzino, aparentava menos idade e brincava com carrinhos em cima da cama, quando o psiquiatra entrou no quarto. Sua condição clínica era delicada, ele corria risco de vida, mas estava calmo, demonstrava mesmo certa alegria por receber tanta atenção das pessoas. A conversa com a médica-residente, com as enfermeiras e com a docente responsável pelo caso mostrou que todos estavam angustiados com a seguinte situação: o Natal se aproximava, o hospital funcionaria quatro dias em esquema de plantão, muitos pacientes estavam recebendo alta. No entanto, temiam que, se dessem licença para o Carlinhos passar o Natal com a família (que residia a 300 km do hospital), ele poderia falecer. Entretanto, caso decidissem mantê-lo em uma enfermaria semideserta, achavam que esse não seria o Natal que uma criança na situação dele merecia.

Propusemos, então, um grupo de discussão, com duração de 30 minutos, a ser realizado na enfermaria no fim daquela manhã. Participaram 12 pessoas, entre alunos, médicos-residentes, enfermeiros e professores. Ao chegarmos, reparamos que conversavam animadamente sobre os preparativos para o feriado. O início da reunião teve um pequeno silêncio, interrompido por várias falas angustiantes sobre como seria duro morrer na época do Natal. No decorrer das discussões, foi ficando claro que todos comungavam dos mesmos sentimentos, destacando-se a culpa pelo abandono que sentiam

impor ao paciente. Repetidamente, voltava a dúvida: dar ou não licença hospitalar. De súbito, um aluno perguntou, simplesmente: “alguém já perguntou pro Carlinhos o que ele gostaria de fazer?”. Foi um desses momentos em que a expressão das pessoas se ilumina e que mudam diametralmente o rumo da discussão. Entre surpresos, aliviados e ainda temerosos, todos se entreolharam e reponderaram que não, que ninguém havia conversado sobre isso com o principal interessado. Ao fim da reunião, determinou-se que o paciente precisaria ser ouvido, que isso deveria ser levado em conta na decisão da equipe. Consultado, ele preferiu passar o Natal com seus pais, e assim foi feito. Após o período de licença, ele retornou ao hospital, onde veio a falecer cinco dias depois. Nesse caso, a principal função da interconsulta foi restabelecer a comunicação entre a equipe assistencial e o paciente, bloqueada por sentimentos conflitantes que paralisavam todos os membros dessa “família” que não queria “abandonar” um filho querido.

É importante enfatizar que a atitude do interconsultor diante do colega médico ou da equipe assistencial nunca será “professoral” ou “psicoterapêutica”. A postura deve ser de um profissional que trabalha simétrica e conjuntamente, tendo em mente a mesma finalidade: melhorar a qualidade da assistência prestada aos pacientes.

Registro no prontuário

As anotações registradas no prontuário devem ser claras, concisas, evitando-se o uso de jargões, mais detalhadas em aspectos importantes e mais concisas no que for secundário. A ideia preconcebida de que o médico não lerá as anotações do psiquiatra não deve orientar a redação, que, entre outras funções, tem importância legal. Deve-se lembrar que o prontuário é um documento passível de análise de terceiros (auditorias, companhias seguradoras, sistema judiciário). Anotações cuidadosas também orientarão, futuramente, o procedimento da equipe assistencial ou de outro profissional de saúde mental que for conduzir o caso.

No registro, deve constar a razão específica, dada pelo médico assistente, para a solicitação de interconsulta. Esse cuidado costuma restringir o campo de responsabilidade do psiquiatra, em caso de ações legais (mais informações sobre aspectos éticos e legais da interconsulta podem ser obtidas no Cap. 28). A história da moléstia atual e das manifestações psiquiátricas, a história psiquiátrica pregressa e o exame do estado atual devem estar registrados no mesmo padrão que se utiliza em psiquiatria. Deve-se registrar recomendações nos casos de risco de conduta auto ou heteroagressiva. Sugestões de como a equipe deve proceder em situações críticas previsíveis devem vir em destaque, ao fim das anotações.

É sempre um motivo de preocupação o que deve ser registrado sobre aquilo que o paciente nos revelou, notadamente quando não se pode restringir o acesso de terceiros a essa documentação. De modo geral, não registramos revelações mais íntimas nem formulações psicodinâmicas detalhadas. É preferível, como se orienta na boa anamnese, escrever o que o paciente falou e relatar seu comportamento, com o mínimo possível de interpretações. É bom não perdermos de vista o seguinte ideal: prover registros de boa qualidade, em documentos adequadamente guardados e protegidos da curiosidade e de qualquer má intenção de terceiros.

Aconselha-se sempre registrar no prontuário as visitas de seguimento e manter a comunicação com o médico assistente. Há certas circunstâncias, como no caso de risco de suicídio ou de

sintomas psicóticos, que exigem que o psiquiatra comunique-se rapidamente com o médico assistente, não se limitando a deixar uma recomendação escrita no prontuário.

A respeito do seguimento do paciente internado, vale o lembrete que sempre fazemos aos profissionais que estagiam em nosso serviço: é preciso *reservar na agenda* os horários para o acompanhamento das interconsultas, como fazemos no caso de pacientes ambulatoriais. Isso evita a incerteza do paciente, que nunca sabe quando verá de novo seu psiquiatra, e poupa o interconsultor de ter que arranjar “um tempinho extra” para rever o paciente, o que, infelizmente, acaba ocorrendo em horários apertados de almoço ou em fins de período.

Um artigo escrito por médicos internistas, com o título “Os dez mandamentos da interconsulta eficaz”, inicia-se com um comentário sobre o tempo que dispendemos fazendo algo tão pouco estudado em suas sutilezas e tão pouco ensinado em nossa instrução formal: a postura a ser mantida quando atendemos pacientes que já se encontram em tratamento com colegas médicos.⁸ Os conselhos, ou “mandamentos”, por eles sugeridos encontram-se no Quadro 8.3 e são válidos em interconsulta de qualquer especialidade e condensam com maestria algumas das ideias expressadas neste capítulo.

QUADRO 8.3

Os dez mandamentos da interconsulta eficaz

1. Determine a razão da interconsulta: entre em contato com o médico assistente para saber, especificamente, por que ele o chamou.
2. Estabeleça o grau de urgência (emergência, urgência, rotina), evitando problemas de comunicação ou demora desnecessária.
3. Faça você mesmo o seu trabalho: colete informações e examine o paciente. Não se contente com o que já se encontra no prontuário.
4. Seja conciso e prático, não repetindo informações já registradas no prontuário.
5. Mantenha a objetividade: recomendações específicas, em vez de vagas.
6. Antecipe prováveis complicações e deixe um plano de ação para manejá-las.
7. Não cobice o paciente do próximo. É seu colega quem deve manter o controle da situação.
8. Ensine só se for com tato: troque ideias, ofereça um artigo ao colega.
9. Discuta seu plano com o médico assistente, notadamente se as recomendações forem cruciais ou potencialmente controversas.
10. Mantenha o acompanhamento durante a internação e planeje o atendimento ambulatorial.

Fonte: Goldman e colaboradores.⁸

Luta contra o “caráter dispensável”

O calcanhar de Aquiles da interconsulta psiquiátrica é seu aparente “caráter dispensável”, no sentido de ser tomada por alguns como pouco importante. Esse pressuposto errôneo pode surgir tanto na mente do médico que solicita a interconsulta quanto na do psiquiatra iniciante em interconsulta.

O médico assistente pode reconfortar-se com a ideia de que, tendo chamado a interconsulta, já propiciou ao paciente certa dose do necessário humanismo. De que não terá que interagir com o psiquiatra, nem valorizar-lhe a prescrição e a orientação. Todo psiquiatra já se sentiu frustrado ao chegar a uma enfermaria e descobrir que, sem prévio aviso, seu paciente de interconsulta tivera alta.

Outra frustração comum é verificar que alguns médicos assistentes não seguem as recomendações deixadas pela psiquiatria. Sentimentos contratransferenciais (como desprezo,

irritabilidade) decorrentes do fato de sua orientação não estar sendo seguida podem abalar a autoestima e dificultar a eficácia da atuação do interconsultor.⁹

Esses elementos da prática clínica mostram a necessidade de o interconsultor desenvolver a capacidade de tolerar a limitação de sua intervenção e de sua função, sem cair na armadilha de achar que, por ser pouco valorizado por alguns colegas, seu trabalho seja mesmo dispensável. A melhor forma de o psiquiatra enfrentar esse potencial desalento é concentrar-se em sua tarefa ao lado dos pacientes, procurando manter a comunicação com as pessoas que deles cuidam. As recompensas, mais cedo ou mais tarde, virão.

REFERÊNCIAS

1. Botega NJ, Mitsuushi GN, Azevedo RCS, Lima DD, Fanger PC, Mauro MLF, et al. Depression, alcohol use disorder and nicotine dependence among patients at a general hospital. *Rev Bras Psiquiatr.* 2010;32(3):250-6.
2. Azevedo RC, Mauro ML, Lima DD, Gaspar KC, da Silva VF, Botega NJ. General hospital admission as an opportunity for smoking-cessation strategies: a clinical trial in Brazil. *Gen Hosp Psychiatry.* 2010;32(6):599-606.
3. Sledge WH, Gueorguieva R, Desan P, Bozzo JE, Dorset J, Lee HB. Multidisciplinary proactive psychiatric consultation service: impact on length of stay for medical inpatients. *Psychother Psychosom.* 2015;84(4):208-16.
4. Sockalingam S, Alzahrani A, Meaney C, Styra R, Tan A, Hawa R, et al. Time to consultation-liaison psychiatry service referral as a predictor of length of stay. *Psychosomatics.* 2016;57(3):264-72.
5. Glickman LS. *Psychiatric consultation in the general hospital.* New York: Marcel Dekker; 1980.
6. Ferrari H, Luchina N, Luchina IL. *La interconsulta médico-psicológica en el marco hospitalario.* Buenos Aires: Nueva Visión; 1977.
7. Kohut H. *La restauración de si-mismo.* Barcelona: Paidós; 1980.
8. Goldman L, Lee T, Rudd P. Ten commandments for effective consultation. *Arch Intern Med.* 1983;143(9):1753-5.
9. Fráguas Jr. R, Botega NJ. Interconsultor em psiquiatria. In: Fráguas Jr. R, Figueiró JAB, editores. *Depressões em medicina interna e em outras condições médicas.* São Paulo: Atheneu; 2000. p. 89-93.

APÊNDICE

Formação profissional e organização de serviços

Um serviço de interconsulta deve estar estruturado para oferecer aos profissionais em treinamento conhecimento e estratégias de ação que os habilitem a diagnosticar e tratar pacientes com transtornos psiquiátricos, bem como a lidar com situações emergentes de natureza psicológica que ocorrem com os pacientes, familiares e equipe assistencial.¹⁻³

Três grandes áreas de conhecimento devem estar presentes na formação do interconsultor e devem orientar um programa de leituras e de seminários teóricos:

1. *Manifestações psiquiátricas* causadas por doenças clínicas, intoxicações e traumas, bem como por procedimentos e tratamentos médicos. Unidades de psiquiatria em hospitais devem diagnosticar e tratar condições comórbidas, clínicas ou cirúrgicas. Isso requer dos residentes de psiquiatria capacitação em medicina geral.
2. *Psicologia médica*. Devido às peculiaridades de seu trabalho, a versatilidade, a personalidade e a criatividade do interconsultor caminham ao lado de seus conhecimentos técnicos. De um lado, sua capacidade de compreender, em uma postura de acolhimento e reflexão, ouvir com empatia os diferentes elementos que participam da situação de interconsulta; de outro lado, sua capacidade de, coletadas as informações, distanciar-se emocionalmente e tomar decisões pragmáticas. Tudo isso conta para o sucesso de suas intervenções, sejam elas focalizadas no paciente, na relação médico-paciente, sejam elas focalizadas na dinâmica institucional.
3. *Funcionamento de grupos e instituições*. Recomenda-se ao interconsultor ter conhecimento e experiência na condução de grupos operativos. Isso lhe permitirá melhor desempenho junto à equipe assistencial e na coordenação de grupos de reflexão sobre a tarefa assistencial. Devido ao papel regulador que as normas institucionais, sejam elas implícitas ou explícitas, exercem sobre as ações e reações dos profissionais, é importante adquirir conhecimentos sobre o funcionamento das instituições assistenciais.

Artigos e números especiais das revistas *Psychosomatics* e *General Hospital Psychiatry* são dedicados à temática da formação em interconsulta. A American Psychiatric Association e a Academy of Psychosomatic Medicine, dos Estados Unidos, bem como a European Association for Consultation-Liaison Psychiatry and Psychosomatics, elaboraram listas detalhadas dos conhecimentos e habilidades essenciais requeridos de um especialista na área.^{4,5}

RECURSOS HUMANOS

A organização de um serviço de interconsulta demanda, além da capacitação técnica, tempo e recursos. É comum o surgimento de várias demandas de trabalho conjunto em assistência, ensino, pesquisa e administração. Será preciso definir prioridades. Inicialmente, deve ser priorizado o atendimento de pacientes internados. Quando essa atividade estiver consolidada, pode-se ampliar a abrangência das tarefas institucionais.

O cálculo da necessidade de pessoal deve considerar o que diversos estudos nacionais indicam: uma interconsulta psiquiátrica é solicitada para 1 a 2,5% dos pacientes internados. Essa taxa é variável e tende a crescer à medida que o trabalho do psiquiatra é reconhecido como importante e eficaz. Estima-se que uma interconsulta, na qual se inclua pelo menos uma visita de seguimento, demandará pelo menos duas horas. No cálculo da carga horária, deve-se considerar o tempo despendido em seminários, reuniões clínicas e outras tarefas institucionais.

A interconsulta é uma situação emergencial

A interconsulta deve ser considerada uma situação emergencial. Não é recomendável adiar o atendimento de uma interconsulta nem programá-lo burocraticamente em um horário pré-fixado. As interconsultas devem ser feitas prontamente, ou porque o paciente tem um problema agudo, ou porque a equipe assistencial está muito aflita. Às vezes, o médico assistente já atingiu o limite de angústia que é capaz de suportar diante de uma situação crítica. Quando solicita a interconsulta, quer a presença urgente do psiquiatra, pois urgente é sua aflição.

Para maior efetividade do serviço, é preciso pensar nas diferentes etapas de uma interconsulta e estruturar uma rotina de funcionamento que assegure seu cumprimento. Nossa experiência com médicos psiquiatras em treinamento no Hospital de Clínicas da Universidade Estadual de Campinas (Unicamp) mostra que, de tempo em tempo, vale a pena conferir se essas etapas vêm sendo cumpridas nos atendimentos. É assim que se tem procurado manter a qualidade do serviço, bem como a confiança entre os colegas que solicitam nosso auxílio profissional.

A interconsulta requer dedicação de tempo

O tempo é necessário pois pode ser demorado encontrar o médico assistente, e, por vezes, o próprio paciente pode não estar disponível, tem-se que ampliar a entrevista aos membros da enfermagem e aos familiares e também revisar o prontuário do paciente, a avaliação do paciente sofre frequentes interrupções, e a equipe assistencial aguarda um retorno do psiquiatra. Além disso, dada a velocidade com que os fatos se sucedem, algumas situações clínicas requerem a presença do psiquiatra com maior frequência.

O psiquiatra de hospital geral costuma ser convidado a participar de uma série de atividades. As demandas vêm de serviços assistenciais e da direção do hospital: medidas de caráter profilático, treinamentos em saúde mental, participação em comissões e projetos de assistência e de pesquisa. O dinamismo requerido para o cumprimento dessas atividades contrapõe-se à espera

passiva por um pedido de interconsulta – em geral contraproducente – e possibilita ao psiquiatra assumir uma atitude receptiva-ativa – e valorizada – no hospital geral.⁶⁻⁸

A interconsulta ambulatorial

O Hospital de Clínicas da Unicamp, assim como muitos hospitais gerais, conta com serviços ambulatoriais em diversas especialidades médicas, entre elas a psiquiatria. Para atender às necessidades de interconsulta psiquiátrica que surgem no contexto de seguimento ambulatorial, foi instituído o Ambulatório de Interconsulta Psiquiátrica. Esse ambulatório funciona como interface entre os ambulatórios do serviço de psiquiatria e os de outras especialidades médicas, permitindo que as especificidades da atividade de interconsulta sejam mantidas.

Inicialmente, a admissão de pacientes ao Ambulatório de Interconsulta se dava mediante agendamento solicitado pelo médico assistente em impresso próprio, semelhante ao do pedido de interconsulta em enfermaria. Com o passar do tempo, constatou-se que tal fluxo era desfavorável à realização de etapas essenciais da interconsulta: o contato inicial com o médico assistente e a devolução da informação após a avaliação.

Foi, então, instituído um “plantão de interconsulta” associado ao ambulatório. Por um período de duas horas a cada manhã, um interconsultor da equipe está disponível no espaço físico do ambulatório para receber diretamente os colegas médicos, que trazem casos e situações a respeito dos quais desejam a interconsulta, sem qualquer necessidade de agendamento prévio.

Tal arranjo favorece a troca de informações entre médico assistente e interconsultor, permite uma resposta imediata a algumas das dúvidas e dificuldades apresentadas e valoriza a implicação do médico assistente no processo de interconsulta. Por vezes, o contato com o plantão de interconsulta já atende à necessidade do médico solicitante. Quando não é esse o caso, o próprio interconsultor marca a data mais próxima para a avaliação do paciente no ambulatório e combina, com o médico assistente, uma ocasião para a devolutiva.

Outra importante função do Ambulatório de Interconsulta Psiquiátrica é permitir a reavaliação de pacientes atendidos durante um período de internação médica quando isso se faz necessário, complementando o trabalho de interconsulta realizado nas enfermarias e aumentando sua resolatividade.

Seminários teóricos e reuniões clínicas

Essas atividades são imprescindíveis. Não ter vinculação com uma equipe e fazer consultoria esporadicamente significa entrar em campo só para “apagar incêndios”. Isso torna crítica a qualidade do trabalho.⁹ Na estruturação de um serviço de interconsulta, é preciso garantir espaço para os bons frutos que seminários teóricos e reuniões clínicas rotineiras costumam produzir. É necessário esse tempo de reflexão:

[...] a presença de uma equipe de interconsulta em um hospital geral indica a coexistência, dentro dessa instituição, de dois tipos de ações médicas: uma que, pelo número de consultas, a índole das mesmas e o objetivo que as anima, apela para uma

ação fundamentalmente ativa, que solucione os problemas; e outra que, por causa do esquema referencial em que opera e da área sobre a qual atua (relação médico-paciente), leva a uma ação reflexiva-continente.¹⁰

As reuniões da interconsulta conformam um espaço para a convivência e a reflexão sobre a tarefa médica. O profissional que aprender bem as técnicas e as sutilezas da interconsulta aumentará sua percepção em relação à problemática de seus pacientes, utilizará melhor suas reações como instrumento semiológico e estará mais capacitado para interagir com colegas de outras especialidades.

REFERÊNCIAS

1. Botega NJ. Consultation-liaison psychiatry in Brazil: psychiatric residency training. *Gen Hosp Psychiatry*. 1992;14(3):186-91.
2. Nogueira-Martins LA. Ensino e formação em interconsulta. *Rev ABPAPAL*. 1993;15(2):68-74.
3. Leentjens AF, Rundell JR, Wolcott DL, Guthrie E, Kathol R, Diefenbacher A. Reprint of: psychosomatic medicine and consultation-liaison psychiatry: scope of practice, processes, and competencies for psychiatrists working in the field of CL psychiatry or psychosomatics. A consensus statement of the European Association of Consultation-Liaison Psychiatry and Psychosomatics (EACLPP) and the Academy of Psychosomatic Medicine (APM). *J Psychosom Res*. 2011;70(5):486-91.
4. Heinrich TW, Schwartz AC, Zimbrea PC, Lolak S, Wright MT, Brooks KB, et al. Recommendations for training psychiatry residents in psychosomatic medicine. *Psychosomatics*. 2014;55(5):438-49.
5. Nisavic M, Shuster JL, Gitlin D, Worley L, Stern TA. Readings on psychosomatic medicine: survey of resources for trainees. *Psychosomatics*. 2015;56(4):319-28.
6. Azevedo RCS, Mauro ML, Lima DD, Gaspar KC, da Silva VF, Botega NJ. General hospital admission as an opportunity for smoking-cessation strategies: a clinical trial in Brazil. *Gen Hosp Psychiatry*. 2010;32(6):599-606.
7. Sledge WH, Gueorguieva R, Desan P, Bozzo JE, Dorset J, Lee HB. Multidisciplinary proactive psychiatric consultation service: impact on length of stay for medical inpatients. *Psychother Psychosom*. 2015;84(4):208-16.
8. Sockalingam S, Alzahrani A, Meaney C, Styra R, Tan A, Hawa R, et al. Time to consultation-liaison psychiatry service referral as a predictor of length of stay. *Psychosomatics*. 2016;57(3):264-72.
9. Guilhermano LG, Botega NJ, Michel R, Garcia Jr C, Machado FG, Cristana F, et al. Consultoria psiquiátrica em hospital geral: inviável ou promissora? *Rev Bras Psiquiatria*. 2000;22(3):130-2.
10. Ferrari H, Luchina N, Luchina IL. La Interconsulta médico-psicológica en el marco hospitalario. Buenos Aires: Nueva Visión; 1977.



Avaliação do paciente

Neury José Botega
Paulo Dalgalarondo

A avaliação psiquiátrica do paciente internado em um hospital geral tem nuances especiais, condicionadas pelas características próprias do ambiente hospitalar, das comorbidades do trabalho cooperativo com a equipe assistencial. Em emergências psiquiátricas, há menos tempo, pouca privacidade e menor possibilidade de relatos confiáveis. A entrevista precisa ser mais estruturada, e o exame do paciente, minucioso e prontamente realizado. Em casos de comportamento violento, será preciso agir antes mesmo do diagnóstico nosológico específico. A interconsulta permite que se avalie, além do estado do paciente, o padrão e a intensidade das relações interpessoais, entrelaçadas com as institucionais. Neste capítulo, que tem caráter geral e introdutório, são abordados alguns instrumentos com que contamos para avaliar o paciente: entrevista, exame psíquico, exame físico, escalas padronizadas e exames complementares.

ENTREVISTA

A entrevista nunca deve adquirir o aspecto de um ato médico mecânico ou rotineiro, ou seja, um simples perguntar ao paciente sobre alguns itens predeterminados a respeito de sua vida. Ela é, de fato, o principal instrumento de trabalho dos profissionais de saúde mental. Uma entrevista realizada com arte e técnica provê informações valiosas para o diagnóstico clínico e para que o psiquiatra possa conhecer melhor o paciente. Além disso, a entrevista bem conduzida permite o início de uma intervenção em saúde mental terapeuticamente exitosa.

O paciente sabe que será avaliado por um psiquiatra?

O psiquiatra deve insistir para que o paciente seja comunicado por seu médico sobre a necessidade de uma avaliação psiquiátrica, com a qual o paciente, idealmente, precisará consentir. Esses cuidados evitam constrangimentos para ambas as partes envolvidas na interconsulta.

O paciente que não esperava a avaliação psiquiátrica, ou que apenas sabia que “um outro médico” viria vê-lo, pode sentir-se inseguro, enganado ou menosprezado. A falha dessa comunicação permite ao interconsultor, entre outras possibilidades, levantar hipóteses sobre dificuldades na relação estabelecida entre o médico e seu paciente.

Antes de começar a entrevista, é preciso informar-se com o médico assistente sobre o que está acontecendo e em que o psiquiatra poderá ajudar. Além de obter dados sobre a situação clínica do paciente, esse também é o momento de conhecer algo da doença e do tratamento a que ele está se submetendo. Isso permitirá que o psiquiatra entre em contato com os avanços da medicina, além de tomar conhecimento de aspectos particulares (técnicas diagnósticas e terapêuticas, aspectos éticos, sociais, etc.) da especialidade médica que solicitou a interconsulta. Isso facilitará a interação com a equipe assistencial e o paciente. Sempre que possível, no devido tempo, é recomendável rever o prontuário e empreender uma entrevista ampliada que inclua membros da equipe assistencial, familiares e também, eventualmente, pacientes do mesmo quarto.

Iniciando a entrevista

Recomenda-se iniciar a entrevista apresentando-se, perguntando ao paciente seu nome e inquirindo se ele sabe por que está sendo visto por um psiquiatra. Caso ele responda negativamente, é bom perguntar por que ele acredita que seu médico solicitou a interconsulta. É conveniente comunicar ao paciente, com clareza e tato, as razões dadas por seu médico, observando-lhe a reação. Também é importante dizer-lhe, nesse primeiro contato, que as informações obtidas serão compartilhadas com o médico assistente.

É importante inteirar-se da história da moléstia atual. Ainda que o psiquiatra já tenha obtido informações de boa qualidade junto ao médico assistente, recomenda-se que se inicie por aí,

observando, além do conteúdo, “como” o paciente faz seu relato. No entanto, a história da moléstia somática atual não precisa, talvez não deva, ser detalhada logo de início. Isso porque é aconselhável, passada essa fase de aproximação, abrir um pouco mais a entrevista.

Falar livremente permite que o entrevistador avalie melhor a personalidade e, às vezes, alguns conflitos do paciente. A fala livre também tem, muitas vezes, uma dimensão catártica, de desabafo, que pode eventualmente ser muito útil e servir de alívio para o paciente.

À medida que o relato progride, as informações vão “se encaixando” em uma determinada estrutura de história, que está na mente do entrevistador e na qual surgirão lacunas. Após a fase de exposição livre, o entrevistador fará as perguntas que faltam para completar e esclarecer os pontos importantes da história e da anamnese de modo geral.

Alguns pacientes que sofrem de dor ou de outros sintomas, com ausência de anormalidades nos exames até então realizados, poderão se sentir ressentidos com a avaliação psiquiátrica, sentindo que menosprezam ou duvidam de seus problemas. Diferentemente dessa situação, há casos em que o paciente “cria”, consciente e voluntariamente, sinal, sintoma ou vivência que, na verdade, não tem (*simulação* de doenças, visando a benefícios econômicos ou previdenciários). Em outras situações, o paciente (ou familiar) *dissimula*, ou seja, nega ou esconde, voluntariamente, a presença de psicopatologia (p. ex., não reconhecendo o caráter autodestrutivo de uma lesão ou negando problemas com bebidas alcoólicas, o que poderia tirá-lo da fila de transplante hepático).

São frequentes situações em que, devido a suas condições clínicas, o paciente não é capaz de relatar seus problemas. Necessitamos, então, de fontes secundárias de informação, em geral de pessoas envolvidas emocionalmente com o paciente, que poderão mesclar fatos com interpretações. Quando não houver nem mesmo essas fontes, poderá haver informações vagas e desencontradas, vindas de membros da equipe assistencial, e o profissional deverá, então, tomar ainda mais cuidado para manter sua neutralidade e buscar informações confiáveis.

Como em toda atividade clínica, a entrevista inicial é, muitas vezes, um momento de suma importância na interconsulta psiquiátrica. Esse primeiro contato visa produzir no paciente uma sensação de confiança e esperança. Nos primeiros contatos, a postura física do entrevistador, seu olhar atencioso, ou seja, toda a riqueza da comunicação não verbal, é muito importante. No entanto, como o paciente geralmente não pede para ver o psiquiatra, este último, a princípio, pode não ser visto como uma fonte potencial de ajuda. Ao contrário, pode ser recebido com aborrecimento. É importante frisar para o paciente que, independentemente de seu diagnóstico, trabalharemos para a melhora de seu estado geral, amenizando alguns sintomas e auxiliando-o na reabilitação.

Na fase inicial da entrevista, o paciente pode estar muito ansioso e usar manobras e mecanismos defensivos, como risos, silêncios, perguntas inadequadas, comentários críticos sobre o profissional, etc. São estratégias involuntárias ou propositais que podem estar sendo utilizadas para que o paciente evite falar de si, de seu sofrimento, de suas dificuldades. O profissional deve lidar com tais situações, lembrando, educadamente, ao paciente que a entrevista tem por objetivo identificar seu problema, para, assim, poder ajudá-lo da melhor forma possível.

Fala-se muito a respeito da entrevista inicial. No entanto, em nossa experiência na atividade de interconsulta, a segunda entrevista também tem especial importância, pois em geral será combinada com o paciente, que, desse modo, irá se dedicar à relação com o profissional. É na segunda entrevista que o paciente pode se abrir mais, depositando sua confiança em nós, pois passa a ter a percepção de que estamos realmente disponíveis para ouvi-lo.

O sigilo

O respeito ao princípio do sigilo profissional garante que o médico não divulgará, sem consentimento do paciente, informações a ele reveladas ou por ele suspeitadas. No caso de interconsultas, recomendamos que, desde logo, o psiquiatra deixe claro ao paciente que todas as informações que sejam imprescindíveis para seu diagnóstico e tratamento serão compartilhadas com o médico assistente. Isso deverá evitar conflitos de interesse e tentativas de manipulação que possam surgir na tríade médico-paciente-psiquiatra. Nos casos em que, após ser encerrada a avaliação, se estabelecer uma relação terapêutica distinta, como no caso da psicoterapia, questões relativas à confidencialidade deverão ser rediscutidas. O Capítulo 28, sobre aspectos éticos e legais, aprofunda-se nesse tema.

Limitações do ambiente hospitalar

Idealmente, médico e paciente necessitam de privacidade e segurança para conversar. Isso deve ser buscado sempre que o paciente possa se deslocar até uma sala próxima. Essa sala deve ter pouco movimento e ruído. Notadamente, em prontos-socorros, deve também ser segura, a fim de que pacientes agitados não machuquem a si ou a outrem, e, se necessário, permitir rápido acesso de outros membros da equipe e do pessoal da segurança.

No hospital geral, na maioria das vezes, a entrevista é realizada em um espaço adaptado, compartilhado por outros, com o paciente acamado. A solução é providenciar uma cadeira, sentar-se próximo do paciente, para que ele possa virar-se em direção ao entrevistador. Assim, será possível falar mais baixo, buscando-se o máximo de privacidade possível. Em algumas situações, visando ao treinamento, alunos ou residentes de medicina estarão participando da entrevista. Em outras, como no caso da avaliação da capacidade de um paciente recusar tratamentos, recomenda-se que o médico assistente esteja presente durante a entrevista.

O estilo da entrevista

É importante que a entrevista seja, ao mesmo tempo, empática e útil. A habilidade do entrevistador, em parte aprendida, em parte intuitiva, “[...] revela-se pelas perguntas que formula, por aquelas que evita formular e pela decisão de quando e como falar ou apenas calar”.¹

Ouvir o paciente: o valor terapêutico dessa atitude do médico é reconhecido há muito tempo. Notadamente, na primeira parte da entrevista, após a apresentação e o reconhecimento do problema que motivou a internação, deve-se ajudar o paciente a se expressar livremente. O

entrevistador manterá uma *escuta ativa*, cujas características encontram-se resumidas no Quadro 2.1 (ver Cap. 2) e aprofundadas no Capítulo 26, sobre abordagem psicodinâmica da crise. Dependendo do paciente e da situação, o entrevistador deve agir de forma distinta (Quadro 9.1).

QUADRO 9.1

As três regras de ouro da entrevista psiquiátrica

1. Pacientes **organizados** (mentalmente), com **inteligência normal**, com escolaridade boa ou razoável, fora de um “estado psicótico”, devem ser entrevistados de forma mais aberta, permitindo-se que falem e se expressem de forma mais fluente e espontânea. O entrevistador fala pouco, fazendo algumas pontuações para que o paciente “conte a sua história”.
2. Pacientes **desorganizados**, com **nível intelectual baixo**, em um **estado psicótico** ou paranoide, “travados” por um alto nível de ansiedade, devem ser entrevistados de forma mais estruturada. Nesse caso, o entrevistador fala mais e faz perguntas mais simples e dirigidas (perguntas fáceis de serem compreendidas e respondidas).
3. Nos primeiros contatos com pacientes **tímidos, ansiosos ou paranoides**, fazer primeiro perguntas neutras (nome, onde mora, profissão, estado civil, nome de familiares, etc.), para apenas gradativamente começar a formular perguntas “mais quentes” (às vezes, constrangedoras para o paciente), como “tem tido problemas ou dificuldades emocionais?”, “como avalia a gravidade de sua doença?”, “tem medo da morte?”, “como está sua relação com sua esposa?”, “o que aconteceu para você ter agredido seus familiares?”, etc. Vale a sabedoria popular, que diz: “*o mingau quente se come pela beirada*”.

Fonte: Dalgalarrondo.¹

O Quadro 9.2 exemplifica alguns tipos de perguntas.² Uma pergunta mais aberta pode ser inadequada quando se entrevista um paciente muito prolixo; uma sugestiva, pouco confiável quando utilizada por um entrevistador pouco experiente. Perguntas alternativas, ou sugestivas, agilizam a exploração. De modo geral, as perguntas altamente estruturadas, como as encontradas em instrumentos psiquiátricos padronizados, não são adequadas para a clínica com pacientes de hospital geral. As perguntas devem ser, de modo geral, curtas e de fácil compreensão.

QUADRO 9.2

Tipos de perguntas durante a entrevista

Pergunta aberta	<i>Como se encontra seu estado de ânimo?</i>
Pergunta alternativa	<i>O senhor está alegre ou triste?</i>
Pergunta sugestiva passiva	<i>O senhor está triste?</i>
Pergunta sugestiva ativa	<i>O senhor está triste, não está?</i>

Fonte: Com base em Rojo Rodes e Cardoner Álvarez.²

Embora a atitude básica do entrevistador na fase inicial da avaliação deva ser a de ouvir com atenção e paciência, isso não significa colocar-se em uma posição totalmente passiva. Assim, Sullivan³ enfatizava que os dados essenciais da clínica psiquiátrica emergem principalmente de uma observação participativa, da interação intensa entre paciente e profissional:

[...] o entrevistador desempenha um papel muito ativo na introdução de interrogações, não para mostrar que é inteligente ou cético, mas literalmente para ter certeza que ele sabe o que está sendo dito. [...]

Quase toda vez que se pergunta “bem, você quer dizer assim e assado?”, o paciente é um pouco mais claro sobre o que ele quer dizer [...].

Reformular o que o paciente diz também o ajuda a perceber melhor por que experiência está passando.

Perguntas que, para alguns, podem ser mais constrangedoras, por exemplo, sobre vida sexual e ideação suicida, devem ser deixadas para um momento em que o paciente esteja mais aberto e confiante. A apreciação do risco de suicídio exige um conjunto de informações, que, aliadas à intuição profissional, permitirão ao médico tomar algumas decisões. É um preconceito pensar que perguntar sobre ideias de suicídio induzirá o paciente a cometê-lo. Ao contrário, a abordagem respeitosa e cuidadosa dos sentimentos do paciente a esse respeito, por si só, tem efeito terapêutico.

Em alguns casos, pode ser impossível para o paciente comunicar-se por meio da fala, o que aumenta sua sensação de desamparo. Na maioria das vezes, pessoas nessa condição estão lúcidas, compreendem o que se passa no ambiente e sentem-se muito acalentadas pela nossa voz, o toque corporal e pequenos gestos que facilitem a comunicação. Escrever sobre uma prancheta ou *tablet*, bem como apontar as letras do alfabeto impressas em um cartão, são formas de superar essa dificuldade.

Quando médico e paciente não falam o mesmo idioma, é aconselhável buscar-se um intérprete “neutro”, fora das relações próximas do paciente.

Profundidade e subjetivismo precisam ser dosados com pragmatismo e objetividade

Abstenha-se de forçar profundidade à entrevista, salvo quando o paciente a requer. Não devem ser procuradas, precocemente, explicações psicológicas para os sintomas. No caso de elas existirem, serão intuídas pelo avaliador, após ter ponderado um conjunto de dados, incluídos os do exame físico e psíquico. É importante lembrar que justamente quando há queixas físicas sem explicação médica é que o paciente não deve ser objeto de questionamento direto e pouco sutil.

A maioria dos pacientes acometidos por esses transtornos responderá “não” à clássica pergunta: “aconteceu alguma coisa importante antes do surgimento dos sintomas?”, seja porque negam a relevância do evento, seja porque não o ligam, emocionalmente, a seu padecimento (Cap. 17).

De modo geral, você deveria procurar identificar as fontes de estresse mais imediatas, às quais o paciente está reagindo, e as preocupações *conscientes* do paciente em relação a elas. O interconsultor que tenta confrontar e interpretar os conflitos *inconscientes* do paciente geralmente não terá sucesso. Esses métodos foram desenvolvidos para tratar pacientes neuróticos que desenvolvem uma aliança terapêutica, que procuram se compreender, e que não estão reagindo, realisticamente, a um estresse. Você raramente verá esse tipo de paciente no hospital geral.⁴

Os eventuais *insights* do psiquiatra interconsultor devem auxiliar seu raciocínio, orientar o manejo do caso e nunca se transformar em interpretações para o paciente, ou em formulações rebuscadas, para a equipe assistencial.

Feitas essas ressalvas, o entrevistador lucrará com um embasamento em aspectos psicodinâmicos, como é a tônica neste livro. É desejável que, ao término da entrevista, tenha conseguido certa compreensão do mundo interno de seu paciente. No entanto, é normal não

compreender, é normal, às vezes, ficar paralisado ou angustiado. Precisamos dessa angústia para depois transformá-la, junto com o paciente, em pensamentos calmos e disponibilidade afetiva.

Os sentimentos despertados pelo paciente devem ser discriminados e pensados, como curiosidade, simpatia, raiva, preocupação, irritação, pena, tristeza, impaciência, tédio, confusão, frustração ou medo. O reconhecimento desses sentimentos modulados pelos mecanismos de transferência e contratransferência (ver Cap. 2) funciona como importante instrumento semiológico e pode, com a prática profissional, o autoconhecimento e a reflexão caso a caso, fazer toda a diferença na avaliação e no manejo de uma situação clínica.

Uma armadilha: “orgânico ou psíquico”?

Pacientes psiquiátricos correm um risco maior de sofrer de doenças físicas (ver Cap. 12), e pessoas com doenças físicas têm maior risco de apresentar sintomas mentais. É de crucial importância para o psiquiatra manter-se atualizado em clínica médica, assim como é importante que médicos em geral possam observar e levar em conta sinais e sintomas que se apresentam sob forma psicológica. No pronto-socorro e na interconsulta, o psiquiatra deverá contar com conhecimentos e habilidades para reconhecer e lidar tanto com as repercussões psicológicas do adoecimento quanto com a possível presença de quadros orgânicos subjacentes aos sintomas mentais (Quadro 9.3)

QUADRO 9.3

Algumas doenças que provocam sintomas psiquiátricos

Cardiovasculares	Isquemia miocárdica, arritmias, miocardite, prolapso da valva mitral, síncope
Respiratórias	Doença pulmonar obstrutiva crônica, embolia pulmonar, asma
Neurológicas	Acidente vascular cerebral, isquemia cerebral transitória, epilepsia, tumores e metástases cerebrais, demências corticais (como Alzheimer) e subcorticais (como Parkinson), tremor essencial, complicações da aids, esclerose múltipla, neurosífilis, <i>miastenia gravis</i>
Endócrinas	<i>Cushing</i> , hiper e hipotireoidismo, feocromocitoma, Addison, hipoglicemia, diabetes melito, diabetes insípido, hiponatremia, intoxicação por água, osteoporose
Reumáticas	Artrite reumatoide, lúpus eritematoso, fadiga crônica, escleroderma, fibromialgia
Nutricionais	Anemia ferropriva, deficiências de tiamina, piridoxina, ácido fólico
Outras	Infecções, tumores, síndromes paraneoplásicas, intoxicações, abstinências

Fonte: Com base em Negro Jr.⁵

A entrevista cuidadosa e o exame do paciente devem, sempre que possível, levar à etiologia do quadro clínico. É temerário o tratamento sintomatológico. Tome-se como exemplo o caso de um paciente com tromboembolismo pulmonar, iniciado com inquietude, mal-estar e ansiedade, para quem só tenha sido feito tratamento sintomatológico, sedando-o, e deixando de se fazer o diagnóstico e tratamento corretos. No hospital geral, há diversas situações como essa, nas quais a acurácia do diagnóstico e a rapidez com que se inicia a terapêutica específica são vitais.

Sinais e sintomas psiquiátricos podem ser as primeiras manifestações de uma patologia física subjacente, sobretudo quando não se encontram fatores psicossociais recentes (p. ex., estresse,

perdas) que possam ter funcionado como precipitantes de doença mental. Deve-se, igualmente, aventar a possibilidade de etiologia orgânica quando os sintomas aparecem pela primeira vez após os 45 anos de idade, bem como na ausência de história pessoal e familiar de transtornos mentais.

Tomando-se por base a observação de que transtornos somáticos encontram-se presentes em considerável proporção das manifestações psiquiátricas encaminhadas ao psiquiatra, a avaliação psiquiátrica no hospital geral deve ser orientada cuidadosamente segundo a seguinte hierarquia: doenças orgânicas, reações emocionais, transtornos psiquiátricos crônicos (Quadro 9.4). Em casos de suspeita de doença neurológica, o tempo de evolução dos sintomas pode auxiliar no diagnóstico diferencial (Quadro 9.5).

QUADRO 9.4

Indicadores que sugerem transtorno mental orgânico

1. **Surgimento dos sintomas psiquiátricos após os 45 anos de idade**
2. **Sintomas psiquiátricos surgem:**
 - No curso de uma doença orgânica já identificada
 - Após uso de drogas com efeitos psicoativos
 - Sem aparentes desencadeantes psicossociais relevantes
3. **História pessoal de:**
 - Abuso ou dependência de álcool ou drogas
 - Distúrbios neurológicos, endócrinos, reumatológicos, hepáticos, renais, cardíacos, pulmonares
 - Traumatismo encefálico
 - Uso concomitante de diversos medicamentos
4. **História familiar de:**
 - Doença cerebral degenerativa ou hereditária
 - Doença metabólica hereditária
5. **Sintomas psiquiátricos:**
 - Alteração do nível de consciência
 - Flutuação do estado mental e nível de consciência ao longo do dia
 - Alterações cognitivas
 - Curso episódico, recorrente ou cíclico
 - Alucinações visuais, táteis ou olfativas
 - Irritabilidade exacerbada, sem desencadeantes significativos
 - Labilidade ou incontinência afetiva
 - Alterações recentes e mudanças bruscas de traços de personalidade
6. **Sinais físicos:**
 - Sinais de disfunção orgânica que possa afetar o cérebro
 - Déficit neurológico focal
 - Convulsão
 - Estupor, catatonia
 - Disfunção subcortical difusa (lentificação da fala e da psicomotricidade, bradipsiquismo, ataxia, descoordenação, tremor, coreia, *asterixis*, disartria)
 - Disfunção cortical (afasia, disfasia, apraxias, agnosias, déficit visuoespacial)

Fonte: Com base em Rojo Rodes e Cardoner Álvarez.²

QUADRO 9.5

Transtornos neurológicos, segundo tempo de evolução

Tempo de evolução	Doença provável
Horas a dias	Acidente vascular cerebral Encefalopatia tóxico-metabólica
Dias a semanas	Hematoma subdural

	Meningite por fungos Neoplasias
Semanas a meses	Doença de Creutzfeldt-Jakob Complexo demência-aids Encefalite límbica paraneoplásica
Meses a anos	Doença de Alzheimer Doença com corpos de Lewy Atrofia corticobasal Paralisia supranuclear progressiva Demências frontais Paralisia geral progressiva Coreia de Huntington Demência vascular Hidrocefalia de pressão intermitente

Fonte: Com base em Mutarelli.⁶

É importante não tomar por pressuposto a ausência (ou presença), afirmada pelo médico, de um transtorno orgânico ocasionando os sinais e sintomas mentais do paciente. Médicos tendem a não ligar as manifestações do pensamento, da afetividade e do comportamento aos problemas orgânicos de base, encarando-os como “funcionais” ou “psicológicos”. O preconceito, o medo ou o simples aborrecimento diante de sintomas psiquiátricos levam o médico clínico a deixar de fazer o diagnóstico.

De modo geral, os pacientes cujos problemas orgânicos não são suspeitados pelo médico assistente têm as seguintes características: despertam medo de uma agressão física; despertam rejeição por características étnicas, culturais ou por seus hábitos e comportamentos; e oferecem ao médico pouca gratificação (intelectual, emocional ou financeira).

Há, no entanto, situações que impedem o médico de suspeitar de um transtorno psiquiátrico, como pacientes que têm atributos pessoais semelhantes aos do médico; que são jovens, atraentes, inteligentes, se expressam bem e são bem-sucedidos; ou, ainda, que oferecem alguma gratificação a seu médico (intelectual, emocional ou financeira). Haveria, nesses casos, de parte do médico, a fantasia de resgatar o paciente, “protegendo-o” do psiquiatra.⁴

Especialmente no contexto de um hospital geral, pode-se ficar em dúvida se a doença física e os medicamentos utilizados representam fator causal ou precipitante. Uma orientação geral é a de que, na condição de dano à estrutura cerebral, sem história prévia de doença mental, se deve pensar em efeito causal direto. Em contraste, quando sintomas depressivos ou maníacos resultam da ação de medicamentos ou de efeitos tóxicos e metabólicos, deve-se pensar em predisposição genética ou constitucional. Nesses casos, a doença física parece precipitar episódios de doença mental, notadamente transtornos do humor, que poderiam surgir espontaneamente ou em resposta a outros fatores adversos.

Em conclusão, o psiquiatra não deve desprezar a frequente base somática de sintomas mentais e comportamentais. Contudo, o fato de o paciente ter tal base somática não deve justificar o encerramento da interconsulta. Assim, não é a etiologia do quadro clínico que deve determinar se o psiquiatra permanecerá ou não envolvido no caso, e sim as reais possibilidades de esse profissional contribuir para a boa condução terapêutica.

ANAMNESE

Foge do escopo deste capítulo o detalhamento da anamnese psiquiátrica. O Quadro 9.6 traz um roteiro de anamnese, com alguns pontos de especial valor na interconsulta psiquiátrica.

QUADRO 9.6

Anamnese psiquiátrica em interconsulta: itens de interesse especial

Identificação e dados sociodemográficos

- Situação conjugal, escolaridade, ocupação, onde e com quem reside, religião, nível socioeconômico, profissão

Motivo da internação e história da moléstia atual

- Diagnóstico, sintomas e limitações mais proeminentes, complicações, tratamento atual, repercussões sobre o estado físico do paciente

Interrogatório complementar

- Pesquisar sintomas relacionados aos vários sistemas e aparelhos, principalmente os relacionados à suspeita clínica

Antecedentes mórbidos pessoais (gerais e psiquiátricos)

- Doenças que necessitaram de várias consultas, acidentes, tentativa de suicídio, enfermidades crônicas, tratamentos importantes, internações, cirurgias, reações a medicamentos (incluindo psicofármacos)

Hábitos e estilo de vida

- Uso, abuso e dependência de drogas lícitas e ilícitas, caracterizando padrão de uso e tratamentos
- Hábitos e afazeres diários, vida social, família, profissão, escola, religiosidade, *hobbies*, lazer, fim de semana

Antecedentes familiares

- Árvore genealógica, doenças crônicas e hereditárias, internações psiquiátricas, dependências químicas, suicídio

História de vida

- Dados relevantes da vida do paciente, diferenciados por etapas: gestação e parto, primeiras habilidades, infância, adolescência, idade adulta, velhice

Aspectos psicossociais especiais

- **Acontecimentos relevantes:** na moradia, no trabalho, nas condições financeiras, na vida amorosa, na vida familiar, acidentes, doenças, internações, falecimentos, perdas, aumento de responsabilidades e de pressões, maiores preocupações recentes e atuais
- **Relacionados à doença:** informação e crenças sobre a doença, atribuição, complicações, impacto em sua vida, limitações impostas, como enfrenta a doença (*coping*), mecanismos de defesa, como reagiu em situações semelhantes no passado
- **Relacionados à internação:** aceitação, impacto, como vivencia limitações, adequação à rotina do hospital, relacionamento com outros pacientes e com a equipe assistencial, visitas, satisfação com o atendimento
- **Relacionados ao tratamento e à recuperação:** informação e crenças, motivação, adesão, temores em relação à incapacitação, dor, mutilação, morte, planos para o futuro
- **Rede de apoio social:** amigos, vida social, religiosidade, com quem tem podido contar, dentro e fora da família, para quem se sente importante

EXAME FÍSICO

Para muitos psiquiatras, é difícil a execução do exame físico. O psiquiatra circula na esfera intrapsíquica e interpessoal de seus pacientes e tem dificuldade para examiná-los fisicamente. Quando realiza o exame físico, pode se sentir inseguro com os achados. Em interconsulta, o dilema se incrementa. Há a ideia de que o paciente não é “seu”, e se pressupõe que o exame físico já foi adequadamente feito pelo médico assistente.

A prática psiquiátrica exige postura médica, especialmente no hospital geral, e isso inclui a realização de exame físico. Este exige treinamento (é sempre possível pedir o auxílio de um colega mais versado) e se beneficia da experiência. Procedendo ao exame físico de seus pacientes, o psiquiatra aprimora sua habilidade. Ao paciente, demonstrará seu interesse, além de transmitir segurança e afeto.

Em muitas situações, alguns sinais da presença de uma síndrome psicorgânica, detectáveis em um bom exame físico e psíquico, ocorrem precocemente, antes de os exames complementares estarem disponíveis ou acusarem problemas. Relembremos que alguns desses indícios podem não ter sido pesquisados, pois a ação e o raciocínio do médico assistente ficaram “bloqueados” (por medo, raiva, insegurança, entre outras possibilidades) diante das manifestações psíquicas do paciente. Ou, ainda, alguns sintomas ligados à organicidade foram observados pelo médico, mas acabaram sendo por ele reputados ao “problema mental” do paciente. Há outra justificativa para o psiquiatra realizar o exame físico: alguns quadros clínicos evoluem com rapidez, e um novo exame poderá revelar anormalidades anteriormente ausentes.

Exame neurológico

Um exame neurológico básico deve ser rotina do psiquiatra que trabalha em hospital geral. Lembramos que, mesmo em pacientes restritos ao leito, podem ser pesquisados os seguintes aspectos: nistagmo, movimentos oculares, tamanho e simetria das pupilas, língua, paresia de membros superiores (mmss) e inferiores (mmii) (sentado, o paciente estende ambos os braços em posição de supinação e fecha os olhos; em caso de lesões cerebrais na área motora, o membro do lado afetado tende a se abaixar ou se mover para propinação).

Lembre-se de que a força muscular dos mmss e mmii nas lesões piramidais é mais facilmente pesquisada nas extremidades, ou seja, na força dos dedos e dos artelhos, que é possível de ser avaliada em pacientes acamados. Outros sinais que podem ser pesquisados no paciente acamado são: tremores, *asterixis*, coordenação motora, atrofia, reflexos tendinosos, reflexos primitivos (*snout*, *grasping*, glabellar, palmomentoniano), Babinski e sinais meníngeos (Kernig, Brudzinski).

Não nos estenderemos na descrição do exame neurológico completo, mas os seguintes pontos devem ser enfatizados:

- Muitas afecções neuronais, responsáveis por quadros neuropsiquiátricos, embora presentes e clinicamente significativas, não produzem sintomas localizatórios. Em muitos casos, embora

haja lesão ou disfunção neurológica, não se identifica um sintoma ou sinal localizatório.

- A avaliação neurológica baseia-se sobretudo no exame neurológico. Neste, a presença de sinais neurológicos claramente patológicos (p. ex., o sinal de Babinski na síndrome piramidal) e as assimetrias são aspectos muito relevantes. O médico deve sempre estar atento à *assimetria* da força muscular nos membros, dos reflexos miotáticos profundos e musculocutâneos superficiais. Deve pesquisar, igualmente, de forma cuidadosa, as diversas alterações sensitivas (tátil, dolorosa, vibratória, térmica, etc.).
- Alguns *sinais e reflexos neurológicos, ditos primitivos*, são de particular importância em neuropsiquiatria. Estes são indicadores de lesão cerebral difusa, encefalopatia, lesões frontais, sem que haja, necessariamente, outros sinais, como
 - **Reflexo de preensão (*grasping*)**: é a resposta de flexão dos dedos evocada pelo contato rápido de um objeto (uma espátula ou o dedo indicador do examinador) com a região palmar (ou plantar) do paciente, ao que este responde com um movimento involuntário de preensão. O *grasping* é considerado uma manifestação motora primitiva, pois é observada em recém-nascidos e em lactentes. Em adultos, o reflexo de preensão tem um importante valor diagnóstico: sendo bilateral, é muito sugestivo de lesão ou disfunção frontal ou de sofrimento cerebral difuso; sendo unilateral, localiza a lesão na área 6 de Broadman contralateral. O *grasping* é o mais significativo dos reflexos primitivos.
 - **Reflexo de sucção**: trata-se de uma resposta primitiva à estimulação da região perioral com uma espátula, na qual há protusão dos lábios, desvio para o lado estimulado e movimentos de sucção. Esse reflexo pode ocorrer em lesões frontais, mas também em encefalopatias difusas.
 - **Reflexo orbicular dos lábios**: a percussão da área acima do lábio superior, na linha média, pode produzir a projeção para a frente dos lábios. A compressão dessa área pode desencadear uma clara projeção dos lábios, como se o indivíduo fizesse um bico ou um focinho (*snout*). Pode indicar dano cerebral difuso.
 - **Reflexo palmomentual**: o estímulo cutâneo da eminência tenar produz a contração do pequeno músculo do mento ipsilateral e sua elevação e, eventualmente, a elevação do lábio inferior ipsilateral à mão estimulada. Esse reflexo pode ser observado em pessoas idosas saudáveis, em indivíduos com lesões piramidais e em quadros encefalopáticos difusos.

Deve-se alertar, aqui, que, de modo geral, os reflexos primitivos são encontrados (e, muitas vezes, normais) em pessoas idosas saudáveis (quanto mais idosas, mais frequente). No entanto, são bem mais indicativos de lesões corticais difusas significativas, sobretudo frontais, em pessoas jovens.

EXAME PSÍQUICO

O exame psíquico, ou exame do estado mental atual, é muito importante na psiquiatria. Apesar de ser necessário o estudo analítico das funções psíquicas isoladas e suas alterações, a separação da vida e da atividade mental em distintas funções psíquicas é artificial. A rigor, não existem funções psíquicas isoladas e alterações psicopatológicas compartimentalizadas desta ou daquela função. É sempre a pessoa na sua totalidade que adoece. As funções perturbadas fazem pressentir transtornos subjacentes, ligados à personalidade como um todo, atingida na sua estrutura e em seu modo de existir.

De modo geral, o exame psíquico deve ser realizado e descrito na seguinte ordem:

- **Aspecto geral:** verificar atentamente aspectos do cuidado pessoal do paciente, higiene, trajes, postura, mímica e atitude global durante a entrevista.
- **Nível de consciência:** estado normal: vigil ou desperto. Alterações quantitativas da consciência: obnubilação, torpor, sopor ou coma. Alterações qualitativas: estado crepuscular, estado dissociativo (histérico) e estado hipnótico. Pacientes aparentemente despertos, mas perplexos e com dificuldade de apreensão do ambiente, podem estar apresentando um quadro de *delirium*.
- **Orientação:** verificar a orientação alopsíquica (quanto ao tempo e ao espaço) e a orientação autopsíquica (quanto a si mesmo). A desorientação temporal ou temporoespacial é frequentemente encontrada no *delirium*, em quadros de apatia intensa (depressões graves), na demência e em quadros de desorganização mental grave (desagregação esquizofrênica, mania).
- **Atenção:** normoprosexia (funcionamento normal), hipoprosexia (diminuição global da atenção e da concentração). Capacidade de concentração e manutenção da atenção sobre determinado objeto (tenacidade) e capacidade de mudar de forma flexível de objeto para objeto (vigilância). Distraibilidade e diminuição da capacidade de fixar a atenção são típicos da síndrome maníaca (hipotenacidade e hipervigilância).
- **Memória:** memória imediata, recente e remota; memória de fixação (que implica percepção, registro e fixação); e memória de evocação. Amnésias orgânicas (menos seletivas psicologicamente, retroanterógrada, mais prejudicados os mecanismos de fixação do que de evocação); amnésias psicogênicas (mais seletivas psicologicamente, mais conteúdos autobiográficos). Pacientes com quadros demenciais devem sempre, por definição, apresentar algum grau de dificuldade mnêmica.
- **Sensopercepção:** ilusão (percepção deformada de um objeto real); alucinação (percepção sem a presença de objeto estimulante; estímulo percebido como vindo de fora do corpo, de forma nítida e corpórea); pseudoalucinação (percepção sem objeto estimulante, sendo o objeto percebido como proveniente da “cabeça” do paciente; não há nitidez sensorial). As ilusões e alucinações visuais são mais frequentemente de etiologia orgânica, enquanto as auditivas estão mais associadas às psicoses funcionais (esquizofrenia, mania e depressão psicótica).
- **Pensamento:** verificar o curso (velocidade e modo de fluir), a forma (estrutura do pensamento) e o conteúdo (temas principais) do pensamento do paciente. Verificar se o

pensamento está lentificado (síndromes depressivas, *delirium*, demências) ou acelerado (síndromes maníacas). Verificar se o pensamento está desorganizado, incoerente ou de difícil compreensão (fuga de ideias, afrouxamento de associações, descarrilhamento, desagregação, pensamento confusional, etc.).

- **Linguagem:** alterações orgânicas da linguagem: afasias, alexias, agrafias. Nas afasias de expressão (Broca), há diminuição da fluência verbal e são frequentes os erros gramaticais; no entanto, a compreensão é preservada. Nas afasias de compreensão (Wernicke), há fluência normal ou aumentada, a fala é incompreensível, e o paciente não entende o que lhe falam. Alterações psiquiátricas da linguagem são: bradifasia, loquacidade (aumento do fluxo sem incoerência), logorreia (aumento do fluxo com incoerência), mutismo, perseverações verbais, ecolalia, mussitação, pararrespostas, neologismos.
- **Juízo de realidade:** identificar se o juízo falso é um erro simples, uma crença cultural ou um delírio. Diferenciar o delírio de ideias prevalentes (ideias errôneas por superestimação afetiva) do de ideias obsessivas (estas são egodistônicas e percebidas como absurdas pelo paciente). Descrever as características do delírio: simples ou complexo; sistematizado ou não sistematizado. Verificar o grau de convicção do paciente, a extensão do delírio (em relação às várias esferas da vida do paciente), a pressão (para agir) e a resposta afetiva do paciente ao seu delírio.
- **Vida afetiva:** estado de humor basal, emoções e sentimentos predominantes. Descrever o humor (depressivo, eufórico, irritado, exaltado, pueril, ansioso, apático, hipomodulado ou aplainado). A labilidade ou incontinência afetiva podem indicar presença de quadro psico-orgânico. A perplexidade patológica, ou seja, um estado de certo estranhamento do mundo, de alheamento levemente ansioso, ocorre com relativa frequência em quadros psicóticos agudos. Verificar se o paciente tem fobias simples (de pequenos animais, objetos cortantes, etc.), fobias sociais (falar em público, falar com pessoas “mais importantes”, ir a festas, etc.) ou agorafobia (fobia de conglomerados, supermercados, estádios, congestionamentos, etc.). Verificar se o paciente já teve crises de pânico (ansiedade aguda, intensa, com descarga autonômica, despersonalização/desrealização, etc.).
- **Volição:** processo volitivo: fases de intenção ou propósito, deliberação, decisão e execução. Verificar se o paciente realiza atos volitivos normais ou apresenta atos impulsivos (“curto-circuito” do ato volitivo). Verificar se há redução da vontade (hipobulia ou abulia). Diferenciar os atos impulsivos (descontrole sem as fases de deliberação e de decisão) dos atos ou rituais compulsivos (“obrigação” para realizar o ato). Verificar automutilações, auto ou heteroagressividade, ideias, planos ou atos suicidas e ideias homicidas. Verificar impulsos patológicos (parafilias). Observar se há negativismo (recusa automática a interagir com as pessoas e/ou com o ambiente).
- **Psicomotricidade:** lentificação ou aceleração. Estereotipias motoras, maneirismos, ecopraxias. Se houver agitação psicomotora, tentar caracterizar (agitação maníaca, confusional, paranoide, oligofrênica, epiléptica, sociopática, etc.). Da mesma maneira, se houver quadro de estupor, tentar caracterizar seu tipo (estupor depressivo, catatônico, psicogênico ou orgânico).
- **Inteligência:** verificar se a inteligência do paciente é normal ou deficitária. Os indivíduos com deficiência intelectual leve podem estudar até o 7º ou o 8º ano e ser independentes, mas

têm problemas com leitura e escrita e dificuldades com conceitos abstratos. Indivíduos com deficiência intelectual moderada conseguem estudar apenas até o 3º ano e realizar, no máximo, tarefas práticas simples estruturadas. É importante lembrar que apresentar bom e rico vocabulário e fraseado (uso de palavras específicas, construções de frases elaboradas e adequadas), empregados de forma adequada, quase sempre exclui deficiência intelectual ou mesmo inteligência limítrofe.

- **Personalidade:** descrever os principais traços que marcam o perfil da personalidade do paciente ao longo de sua vida. Lembrar que a personalidade se caracteriza por ser estável e corresponde ao modo de ser do indivíduo após a adolescência, nas suas relações interpessoais e formas de reagir ao ambiente. Não tomar o aspecto momentâneo do paciente (sobretudo em situações anômalas, como a de doenças e hospitalizações) como a principal fonte para identificar sua personalidade (ou seus transtornos). O que mais conta é o padrão de modos de ser, sentir e reagir ao longo de toda a vida (que é relatado pelo paciente e, sobretudo, por pessoas próximas que convivem há tempos com ele).
- Por fim, devem ser registrados os **sentimentos contratransferenciais** (ver Cap. 2), a **capacidade crítica** do paciente em relação aos seus sintomas e comportamentos, assim como se ele apresenta **desejo de ser ajudado**.
- **Súmula do exame:** ao fim, o exame psíquico (assim como toda anamnese) deve ser redigido com uma linguagem simples, precisa e compreensível. O relato deve ser pormenorizado, mas não prolixo, detalhado em relação ao que é essencial ao caso e conciso no que é secundário.

ESCALAS PADRONIZADAS

Transtornos cognitivos, transtornos afetivos e problemas decorrentes do uso do álcool são altamente prevalentes no hospital geral. Para o aprofundamento a respeito dessas condições clínicas, recomendamos a leitura dos respectivos capítulos. Apresentamos aqui e no Capítulo 10 (Interconsulta de pacientes idosos) alguns instrumentos que têm-se mostrado úteis, tanto para ampliar a visão inicial do avaliador quanto para mensurar sintomas ao longo do tratamento. Eles se encontram no fim dos capítulos. É útil portar cópia deles ao avaliar o paciente.

Os testes que avaliam a cognição encontram-se discutidos e anexados no Capítulo 10. Eles auxiliam bastante, tendo em vista a alta prevalência de síndromes psicorgânicas no hospital geral e o fato de, nessas condições, o exame neurológico produzir poucos, ou nenhum, sinais localizadores de lesão. De modo geral, os pacientes aceitam de bom grado os testes e escalas, quando se explica que fazem parte da rotina de avaliação.

Escala Hospitalar de Ansiedade e Depressão (Hospital Anxiety and Depression Scale – HAD)

Sintomas somáticos encontrados na ansiedade e na depressão apresentam-se com frequência em pacientes com doenças clínicas. Em casos de comorbidade, os sintomas psicológicos, mais do que os somáticos, discriminam melhor entre transtornos do humor e outras doenças clínicas. Com essa preocupação, foi desenvolvida a HAD,⁷ uma escala de autopreenchimento com 7 itens para ansiedade e 7 para depressão. Não figuram itens como insônia, fadiga, taquicardia, anorexia, perda de peso, etc., que podem, também, ser sintomas de doenças físicas. A pontuação em cada subescala vai de 0 a 21.

A HAD tem sido amplamente utilizada tanto para rastreamento diagnóstico quanto para medir a gravidade de ansiedade e de depressão.⁸ A versão em português desse instrumento foi validada entre pacientes internados em uma enfermaria de clínica médica, em pacientes ambulatoriais e sujeitos sadios.^{9,10} Em cada uma das subescalas, pontuações acima de 7 são sugestivas de quadros de ansiedade ou de depressão. A escala HAD encontra-se no fim deste capítulo.

Audit (Alcohol Use Disorder Identification Test)

O AUDIT é útil para auxiliar no diagnóstico de síndrome de dependência de álcool (vide a escala anexada a este capítulo). Esse instrumento foi desenvolvido pela Organização Mundial da Saúde (OMS) com o objetivo de identificar usuários de álcool que se encontrem em uma faixa de risco. Foi utilizado, no Brasil, entre pacientes internados em várias enfermarias de um hospital geral.¹¹ No AUDIT, 10 itens exploram o consumo de álcool, sintomas de dependência e consequências pessoais e sociais do beber. A pontuação igual ou superior a 8 indica a necessidade de uma avaliação mais aprofundada e de um diagnóstico específico.¹²

EXAMES COMPLEMENTARES

O exame do *líquido cerebrospinal* fornece informações valiosas em várias doenças que produzem sintomas psiquiátricos, como encefalites, meningites, hemorragia subaracnoide, doenças inflamatórias, neoplasias e infecções do sistema nervoso central (SNC) (Quadro 9.7).

QUADRO 9.7

Alterações do líquido cerebrospinal e transtornos mentais orgânicos

Proteínas elevadas

- Uremia, hipotireoidismo, intoxicação por lítio, paralisia geral (neurosífilis), meningite fúngica, toxoplasmose, panencefalite esclerosante, aids, encefalopatia de Corsellis, sarcoidose, doença de Behçet

Imunoglobulinas elevadas

- Hipotireoidismo, paralisia geral, panencefalite esclerosante, aids, encefalopatia de Corsellis, sarcoidose, doença de Behçet

Aumento de células

- Pseudotumor, hipoparatiroidismo, encefalopatia aguda pós-diálise, sarcoidose, doença de Behçet, infecções

Fonte: Com base em Rojo Rodas e Cardoner Álvarez.²

A contraindicação mais importante à realização do exame do líquido cerebrospinal é a pressão intracraniana aumentada. A redução abrupta dessa pressão, consequente da retirada do líquido cerebrospinal, pode produzir herniação tentorial ou cone medular por pressão, sendo tais eventos potencialmente fatais. Portanto, a punção liquórica é contraindicada quando há papiledema ou sinais sugestivos de síndrome de hipertensão intracraniana (cefaleia intensa, vômitos, etc.).¹³ A punção do líquido cerebrospinal deve ser precedida de tomografia computadorizada de crânio sempre que houver sinais neurológicos focais, convulsões, história de doença neurológica recente e aids.¹⁴

As provas imunológicas que se realizam no sangue podem, em muitos casos, ser realizadas no líquido cerebrospinal. Em relação à neurosífilis, o diagnóstico revela-se por um líquido cerebrospinal reativo no VDRL, com elevação de proteínas e de células brancas. Entretanto, em alguns casos de neurosífilis tardia, pode-se encontrar um VDRL negativo ou mesmo não se verificar aumento de proteínas e de linfócitos. Nesses casos, apenas o FTA-ABS no líquido cerebrospinal pode confirmar a existência de neurosífilis. Nos casos de infecções virais, dispõe-se atualmente de testes que utilizam o PCR (*Polymerase Chain Reaction*), que podem identificar o agente etiológico específico. Cabe assinalar que um líquido cerebrospinal normal não afasta absolutamente processos patológicos no SNC, principalmente aqueles localizados no interior do parênquima cerebral.¹⁴

Além do exame do líquido cerebrospinal, uma série de exames e dosagens sanguíneas é de especial interesse para o diagnóstico diferencial em interconsulta psiquiátrica e neuropsiquiatria (Quadro 9.8).

QUADRO 9.8

Exames e dosagens sanguíneas de utilidade em interconsulta psiquiátrica e diagnóstico diferencial em neuropsiquiatria

Exame	Que tipo de alteração identifica	Condições neuropsiquiátricas de interesse (diagnósticos diferenciais)
Hemograma	Anemias, quadros infecciosos, leucopenias, leucoses, trombocitopenias, etc.	<i>Delirium</i> em quadros tóxico-infecciosos, em anemias graves e leucoses, linfopenia em síndromes de imunodepressão Mielotoxicidade associada a psicofármacos (carbamazepina, clozapina, fenotiazinas, etc.)
T4 livre e TSH	Hipotireoidismo ou hipertireoidismo (clínicos ou subclínicos)	Quadros depressivos associados ao hipotireoidismo (ou mesmo ao hipertireoidismo), quadros de irritabilidade e/ou mania associados ao hipertireoidismo. Demência associada ao hipotireoidismo.
Sorologias para lues	Neurossífilis	Quadros maníacos, depressivos ou demenciais associados à neurosífilis
Sorologias para aids	Encefalopatia da aids. Atentar para possíveis infecções (ou tumores) associados à aids	<i>Delirium</i> , demências, quadros maníacos, depressivos, quadros de estupor ou quadros psicóticos associados à encefalopatia da aids ou a infecções do SNC associadas à aids
AST, ALT e gama GT	Hepatopatias em geral. Hepatopatias ou hepatotoxicidade associadas ao álcool ou a psicofármacos.	<i>Delirium</i> ou demência associados a hepatopatias. Hepatotoxicidade de psicofármacos, como ácido valproico, carbamazepina, etc. Suspeita de uso abusivo ou de dependência de álcool.
Glicemia	Diabetes melito, hiper ou hipoglicemia	Hiperglicemia: fadiga, fraqueza, desânimo, polidipsia, poliúria Hipoglicemia: agitação psicomotora, episódios de agressividade, <i>delirium</i>
Cortisol sérico	Síndrome de Addison Síndrome de Cushing	Quadros psicóticos, depressivos ou maníacos
Ureia e creatinina	Nefropatias e nefrotoxicidade	<i>Delirium</i> . Nefrotoxicidade associada a psicofármacos
Dosagem de vitamina B12	Síndromes carenciais associadas à deficiência de vitamina B12	Quadros de <i>delirium</i> ou demência associados à deficiência de vitamina B12
Dosagens ou screenings para álcool, canabinoides, cocaína e opioides	Abuso e/ou dependência de álcool e/ou drogas	Diagnóstico diferencial de quadros psicóticos, maniatiformes ou <i>delirium</i> induzidos por drogas (em contraposição à quadros psiquiátricos primários)

O eletrencefalograma (EEG) é útil no diagnóstico diferencial dos quadros confusionais agudos, da epilepsia e também dos distúrbios do sono. As frequências das ondas cerebrais são de diferentes ritmos: beta (igual ou maior que 13 hz), alfa (entre 8 e 13 hz), teta (entre 4 e 8hz) e delta (menos que 4 hz).

Uma lentificação do ritmo de vigília é útil para diferenciar o paciente com *delirium* daquele com um transtorno psiquiátrico funcional. De modo geral, quanto mais grave e aprofundado o *delirium*, maior a lentificação do traçado do EEG. As únicas exceções a isso são os casos de abstinência de álcool ou de drogas sedativas, quando o EEG tem atividade de fundo excessivamente rápida.

Lentificações no traçado são observadas também na vigência de quadros demenciais e em pacientes medicados com lítio, fenotiazinas, tricíclicos, anticonvulsivantes e narcóticos. As assimetrias indicam possível lesão cerebral localizada. A sensibilidade do EEG não é absoluta nos transtornos epiléticos, e suas eventuais alterações são inespecíficas em doenças psiquiátricas funcionais.

A validade desse exame pode ser incrementada por meio de EEG repetidos, EEG após privação de sono, hiperventilação ou estimulação luminosa, eletrodos nasofaríngeos, registro de

24 horas, registro aliado a gravação em vídeo, potenciais evocados e EEG computadorizado. Anomalias no exame de potenciais evocados podem aparecer na esclerose múltipla, por exemplo, sugerindo base neurológica para um quadro mental. Esse exame pode ser útil, também, na diferenciação entre transtornos orgânicos e psicogênicos, como na cegueira e surdez histéricas, em quadros de catatonia com mutismo.

Os Quadros 9.9 e 9.10 sugerem ao psiquiatra os principais exames que devem ser solicitados em algumas situações clínicas frequentemente encontradas na prática diária.

QUADRO 9.9

Exames laboratoriais úteis em pacientes dependentes ou que abusam de álcool e/ou drogas

Abuso de álcool ou fase inicial de dependência	Hemograma completo, gamaglutamiltransferase (gama GT), AST e ALT. Se houver elevações de gama GT, AST ou ALT, realizar a sorologia para hepatite B e C. Se houver queixa digestiva: endoscopia digestiva alta (EDA)
Pacientes dependentes de álcool	Idem ao anterior. Níveis séricos de proteínas totais e de albumina, tempo de protrombina (índice RNI), dosagem de magnésio sérico e endoscopia digestiva alta. Se houver elevação de gama GT, AST ou ALT, realizar a sorologia para hepatite B e C. Raio X de tórax, ECG e Mantoux.
Pacientes que abusam ou que são dependentes de drogas como maconha, cocaína, opioides, etc.	Hemograma completo, gamaglutamiltransferase (gama GT), AST e ALT, sorologia para hepatite B e C. Pesquisa de sífilis e HIV. Raio X de tórax, ECG e Mantoux.

Fonte: Com base em Dalgalarondo e Moraes.¹⁴

QUADRO 9.10

Exames laboratoriais úteis em pacientes adultos após o primeiro episódio de um transtorno psiquiátrico psicótico

Suspeita clínica	Exames a serem solicitados
Quadro neuropsiquiátrico (encefalites, tumores do SNC, hemorragias)	Tomografia computadorizada ou ressonância magnética de crânio. Líquido cefalorraquidiano, hemograma completo com VHS, eventualmente EEG.
Infecções	Hemograma completo com VHS, sorologia para HIV e sífilis, Mantoux
Doenças sistêmicas	Hemograma completo com VHS, raio X de tórax, ECG, EEG, Mantoux
Alterações hormonais e diabetes	T4 livre e TSH, glicemia
Substâncias psicoativas	Investigação cuidadosa de possíveis drogas de abuso e intoxicantes. Se necessário, <i>screening</i> urinário de drogas.

Fonte: Com base em Dalgalarondo e Moraes.¹⁴

Os exames de neuroimagem estrutural (tomografia computadorizada, ressonância magnética) e funcional (tomografia computadorizada por emissão de fóton único – SPECT, ou de pósitrons – PET, determinação do fluxo sanguíneo regional e ressonância magnética espectrométrica e funcional) são de grande auxílio para o diagnóstico diferencial.

A *tomografia computadorizada* baseia-se na atenuação de raios X ao atravessarem as diferentes estruturas do SNC. Permite boa visualização de estruturas ósseas e do líquido cefalorraquidiano (excelente no diagnóstico de neoplasias meníngeas, tumor de hipófise, lesões calcificadas, fraturas ósseas). No entanto, não consegue discernir bem entre substâncias cinzentas

e branca (pouca informação sobre malformações vasculares, tumores de fossa posterior, do tronco cerebral, de áreas temporais e apicais). O uso de contraste iodado incrementa a capacidade diagnóstica, mas aumenta o risco para o paciente.

A *ressonância magnética* baseia-se na distribuição dos núcleos de hidrogênio e em seu comportamento quando submetidos a um campo magnético. Obtêm-se imagens mais nítidas do que com a tomografia computadorizada, com boa diferenciação entre substâncias cinzenta e branca. Em contraposição, esse exame não detecta bem os ossos e as estruturas calcificadas. Indica-se a ressonância magnética quando há suspeita de doenças desmielinizantes, lesões focais causando epilepsia, neoplasias não meníngeas, malformações vasculares, lesões de fossa posterior, tronco cerebral, áreas temporais e apicais e enfermidades degenerativas. Não se pode utilizar a ressonância magnética em portadores de marca-passo, implantes ou corpos estranhos metálicos (risco de deslocamento, por atração magnética, e de esquentamento do metal). Pacientes claustrofóbicos necessitam ser preparados – mais comumente sedados.

A SPECT, realizada após injeção de radioisótopos (o mais utilizado é o tecnécio), fornece informações de estruturas corticais e subcorticais, relacionadas a fluxo sanguíneo e metabolismo cerebral (glicose e oxigênio). A realização de uma SPECT ictal (injeção do radioisótopo durante a crise) permite diferenciar a crise epilética da pseudocrise. Uma utilidade clínica relevante da SPECT é o auxílio na diferenciação entre síndromes depressivas com déficit cognitivo funcional e quadros de demência (principalmente associados à doença de Alzheimer) com sintomas depressivos. O padrão da SPECT nas síndromes depressivas primárias tende a ser o de uma hipoperfusão em região frontal, enquanto, na doença de Alzheimer, tende a ser o de uma hipoperfusão em região parietal ou parietotemporal.

O Capítulo 10, sobre interconsulta de pacientes idosos, ilustra a importância da neuroimagem nesse grupo de pacientes.

REFERÊNCIAS

1. Dalgalarondo P. Psicopatologia e semiologia dos transtornos mentais. 2. ed. São Paulo: Artes Médicas; 1998.
2. Rojo Rodes JE, Cardoner Álvarez N. Abordaje del paciente. In: Rojo Rodes JE, Cirera Costa E. Interconsulta psiquiátrica. Barcelona: Masson; 1997.
3. Sullivan HS. A entrevista psiquiátrica. Rio de Janeiro: Interciência; 1983.
4. Glickman LS. Psychiatric consultation in the general hospital. New York: Marcel Dekker; 1998.
5. Negro Jr PJ. A natureza da dissociação. Um estudo sobre experiências dissociativas associadas a práticas religiosas [dissertação]. São Paulo: Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo; 1999.
6. Mutarelli EG. Demências. RBM; 1999;56:30-4.
7. Zigmond AS, Snaith RP. The hospital anxiety and depression scale. Acta Psychiatr Scand. 1983;67(6):361-70.
8. Bjelland I, Dahl AA, Haug TT, Neckelmann D. The validity of the hospital anxiety and depression scale. An updated literature review. J Psychosom Res. 2002;52(2):69-77.
9. Botega NJ, Bio MR, Zomignani MA, Garcia Jr C, Pereira WAB. Transtornos de humor em enfermaria de clínica médica e validação de escala de medida (HAD) de ansiedade e depressão. Rev Saúde Pública. 1995;29(5):355-63.
10. Botega NJ, Pondé M, Medeiros P, Lima MG, Guerreiro CAM. validação da escala hospitalar de ansiedade e depressão (HAD) em pacientes epiléticos ambulatoriais. J Bras Psiquiatr. 1998;47(6):285-9.
11. Figlie NB, Pillon SC, Laranjeira RR, Dunn J. AUDIT identifica a necessidade de interconsulta específica para dependentes de álcool no hospital geral? J Bras Psiquiatr. 1997;46(11):589-93.
12. Barbor TE, La Fuente JR, Saunders J, Grant M. AUDIT: the alcohol use disorders identification test: guidelines for use in primary health care. WHO PSA. 1992;4:1-29.
13. Haerer AF. Dejong's the neurologic examination. New York: Lippincott-Raven; 1992.
14. Dalgalarondo P, Moraes MJ. Alterações orgânicas e exames laboratoriais: uma revisão para o psiquiatra clínico. In: Brasil MAA, Botega NJ. Programa de educação continuada. Rio de Janeiro: Guanabara-Koogan; 1994.

ESCALA HOSPITALAR DE ANSIEDADE E DEPRESSÃO – HAD

Nome: _____ Data: _____

Por favor, leia todas as frases. Marque com um “X” a resposta que melhor corresponder a como você tem se sentido na última semana.

Não é preciso ficar pensando muito em cada questão. Vale mais a sua resposta espontânea.

A Eu me sinto tenso ou contraído

- 3 () A maior parte do tempo
- 2 () Boa parte do tempo
- 1 () De vez em quando
- 0 () Nunca

D Eu ainda sinto gosto (satisfação) pelas mesmas coisas de que costumava gostar

- 0 () Sim, do mesmo jeito que antes
- 1 () Não tanto quanto antes
- 2 () Só um pouco
- 3 () Já não sinto mais prazer em nada

D Eu ainda sinto gosto (satisfação) pelas mesmas coisas de que costumava gostar

- 0 () Sim, do mesmo jeito que antes
- 1 () Não tanto quanto antes
- 2 () Só um pouco
- 3 () Já não sinto mais prazer em nada

A Eu sinto uma espécie de medo, como se alguma coisa ruim fosse acontecer

- 3 () Sim, de um jeito muito forte
- 2 () Sim, mas não tão forte
- 1 () Um pouco, mas isso não me preocupa
- 0 () Não sinto nada disso

D Dou risada e me divirto quando vejo coisas engraçadas

- 0 () Do mesmo jeito que antes
- 1 () Atualmente um pouco menos
- 2 () Atualmente bem menos
- 3 () Não consigo mais

A Estou com a cabeça cheia de preocupações

- 3 () A maior parte do tempo
- 2 () Boa parte do tempo
- 1 () De vez em quando

0 () Raramente

D Eu me sinto alegre

3 () Nunca

2 () Poucas vezes

1 () Muitas vezes

0 () A maior parte do tempo

A Consigo ficar sentado à vontade e me sentir relaxado

0 () Sim, quase sempre

1 () Muitas vezes

2 () Poucas vezes

3 () Nunca

D Estou lento (lerdo) para pensar e fazer as coisas

3 () Quase sempre

2 () Muitas vezes

1 () De vez em quando

A Tenho uma sensação ruim de medo (como um frio na espinha ou um aperto no estômago...)

0 () Nunca

1 () De vez em quando

2 () Muitas vezes

3 () Quase sempre

D Eu perdi o interesse em cuidar da minha aparência

3 () Completamente

2 () Não estou mais me cuidando como eu deveria

1 () Talvez não tanto quanto antes

0 () Me cuido do mesmo jeito que antes

A Eu me sinto inquieto, como se eu não pudesse ficar parado em lugar nenhum

3 () Sim, demais

2 () Bastante

1 () Um pouco

0 () Não me sinto assim

D Fico esperando animado as coisas boas que estão por vir

0 () Do mesmo jeito que antes

1 () Um pouco menos do que antes

2 () Bem menos do que antes

3 () Quase nunca

A De repente, tenho a sensação de entrar em pânico

3 () A quase todo momento

2 () Várias vezes

1 () De vez em quando

0 () Não sinto isso

D Consigo sentir prazer ao assistir um bom programa de TV, de rádio, ou quando leio alguma coisa

0 () Quase sempre

1 () Várias vezes

2 () Poucas vezes

3 () Quase nunca

AUDIT (THE ALCOHOL USE DISORDER IDENTIFICATION TEST)

Nome: _____ Data: _____

1. Qual a frequência do seu consumo de bebidas alcoólicas?

- [0] nenhuma
- [1] uma ou menos de uma vez por mês
- [2] 2 a 4 vezes por mês
- [3] 2 a 3 vezes por semana
- [4] 4 ou mais vezes por semana

2. Quantas doses contendo álcool você consome em um dia típico quando você está bebendo?

- [0] nenhuma
- [1] 1 a 2
- [2] 3 a 4
- [3] 5 a 6
- [4] 7 a 9

3. Qual a frequência com que você consome 6 ou mais doses de bebida alcoólica em uma ocasião?

- [0] nunca
- [1] menos que mensalmente
- [2] mensalmente
- [3] semanalmente
- [4] diariamente ou quase diariamente

4. Com que frequência, durante os últimos 12 meses, você percebeu que não conseguia parar de beber, depois de ter começado?

- [0] nunca
- [1] menos que mensalmente
- [2] mensalmente
- [3] semanalmente
- [4] diariamente ou quase diariamente

5. Quantas vezes, durante o ano passado, você deixou de fazer o que era esperado devido ao uso de bebidas alcoólicas?

- [0] nunca

- [1] menos que mensalmente
- [2] mensalmente
- [3] semanalmente
- [4] diariamente ou quase diariamente

6. Quantas vezes, durante os últimos 12 meses, você precisou de uma primeira dose pela manhã para sentir-se melhor depois de uma bebedeira?

- [0] nunca
- [1] menos que mensalmente
- [2] mensalmente
- [3] semanalmente
- [4] diariamente ou quase diariamente

7. Quantas vezes, durante o ano passado, você se sentiu culpado ou com remorso depois de beber?

- [0] nunca
- [1] menos que mensalmente
- [2] mensalmente
- [3] semanalmente
- [4] diariamente ou quase diariamente

8. Quantas vezes, durante o ano passado, você não conseguiu lembrar o que aconteceu na noite anterior, porque você estava bêbado?

- [0] nunca
- [1] menos que mensalmente
- [2] mensalmente
- [3] semanalmente
- [4] diariamente ou quase diariamente

9. Você foi criticado pelo resultado das suas bebedeiras?

- [0] nunca
- [1] menos que mensalmente
- [2] mensalmente
- [3] semanalmente
- [4] diariamente ou quase diariamente

10. Algum parente, amigo, médico ou qualquer outro profissional da área de saúde referiu-se às suas bebedeiras ou sugeriu a você parar de beber?

- [0] nunca
- [1] menos que mensalmente
- [2] mensalmente
- [3] semanalmente

[4] diariamente ou quase diariamente



Interconsulta de pacientes idosos

Lucas Francisco Botequio Mella
Florindo Stella

Durante uma internação no hospital geral, os idosos podem apresentar sintomas decorrentes da reação psicológica à doença e de transtornos psiquiátricos primários, como depressão, ansiedade e transtornos da personalidade. Contudo, as particularidades da interconsulta psiquiátrica nessa faixa etária são as alterações do comportamento e da cognição secundárias a patologias neurodegenerativas e cerebrovasculares e a condições médicas gerais. Nesse cenário, alterações de humor, agitação psicomotora e agravamento de sintomas cognitivos são os principais motivos das requisições por interconsulta. Doença de Alzheimer, doença cerebrovascular, doença de Parkinson, demência por corpúsculos de Lewy e degeneração lobar frontotemporal são condições que comumente o psiquiatra interconsultor encontra. Ademais, os distúrbios metabólicos e hidreletrolíticos, os processos infecciosos e a própria hospitalização constituem causas frequentes de descompensações das doenças de base e podem deflagrar ou agravar sintomas cognitivos e alterações de comportamento. Dessa forma, os objetivos deste capítulo consistem em nortear a avaliação cognitiva e neuropsiquiátrica do paciente idoso no hospital geral e descrever os principais aspectos clínicos e abordagens terapêuticas das causas mais comuns de demência e sintomas comportamentais.

Estima-se que o número de pessoas com mais de 60 anos irá aumentar 300% nos próximos 50 anos em todo o mundo. Os países menos desenvolvidos, como o Brasil, e a faixa etária com mais de 80 anos representam as maiores taxas de crescimento.¹ Com o envelhecimento populacional, o número de novos casos de demência dobra a cada cinco anos. As causas mais frequentes de demência são a doença de Alzheimer (DA) e a doença cerebrovascular, que correspondem a aproximadamente 75% dos casos.²

Geralmente, o hospital geral é o cenário onde pacientes já com diagnóstico de demência apresentam agravamento dos sintomas cognitivos e comportamentais. No entanto, algumas vezes, o diagnóstico de uma doença neurodegenerativa ou cerebrovascular subclínica ocorre por meio da investigação de alterações da cognição e do comportamento, que se tornam mais evidentes durante a internação.

É fundamental que o psiquiatra interconsultor esteja capacitado para o manejo das síndromes cognitivas e neuropsiquiátricas e a abordagem diagnóstica das suas principais etiologias. As ferramentas clínicas essenciais para o diagnóstico diferencial são a entrevista clínica, o exame minucioso dos domínios da cognição e do comportamento e a solicitação e a interpretação de exames de laboratório e de neuroimagem.

O sucesso do tratamento é determinado pelo diagnóstico correto das causas de base e dos fatores precipitantes dos sintomas durante a internação, pelo uso criterioso e sistematizado de terapêuticas farmacológicas e não farmacológicas e pelo cuidado com os efeitos adversos dos psicofármacos, mais prevalentes e mais graves em idosos.

AVALIAÇÃO COGNITIVA, NEUROPSIQUIÁTRICA E FUNCIONAL

Entrevista clínica

A avaliação do idoso internado inicia-se com a entrevista psiquiátrica diretamente com o paciente e, adicionalmente, com o familiar, o cuidador e o médico assistente que solicitou a interconsulta. Uma anamnese abrangente, detalhada e com boa acurácia contribui, de maneira crucial, para o estabelecimento das hipóteses diagnósticas e o entendimento da evolução clínica. Cabe ressaltar que, por fatores culturais e desinformação, declínio de memória, depressão, apatia e distúrbios do sono frequentemente são atribuídos ao envelhecimento normal por familiares e, não raramente, por profissionais da saúde, induzindo a equívocos no diagnóstico.³

Já na coleta dos dados de identificação, a escolaridade, a história profissional e as atividades cotidianas do paciente ajudam a estimar a reserva cognitiva, ou seja, o nível de desempenho cognitivo e funcional atingido previamente à instalação da doença. Essa estimativa serve de comparação em relação ao desempenho atual do sujeito, colaborando para a determinação de haver ou não um declínio cognitivo e/ou comportamental, qual sua intensidade e qual seu impacto na funcionalidade.

No detalhamento da história clínica, é fundamental para o diagnóstico diferencial da doença de base identificar quais foram os sintomas iniciais do quadro atual, como surgiram (aguda, subaguda ou insidiosamente) e seu padrão de evolução (progressivo, flutuante ou estável). Para a elucidação das causas da piora do quadro clínico ou do aparecimento de novos sintomas – situações que são frequentes durante internações –, é imprescindível caracterizar os possíveis fatores deflagradores, agravantes e de eventual melhora.

Devem-se levantar os antecedentes patológicos pessoais de transtornos psiquiátricos (transtornos do humor, uso de substâncias psicoativas, esquizofrenia, transtornos da personalidade) e neurológicos (doença de Parkinson, epilepsia, acidente vascular cerebral [AVC]), que podem atuar como contribuintes, fatores de risco ou pródromos do declínio cognitivo, neuropsiquiátrico e funcional. É importante também averiguar a presença de fatores de risco cerebrovasculares (hipertensão arterial sistêmica, diabetes, dislipidemia, tabagismo, obesidade, sedentarismo), que podem orientar o raciocínio diagnóstico para etiologia vascular de sintomas cognitivos e comportamentais.

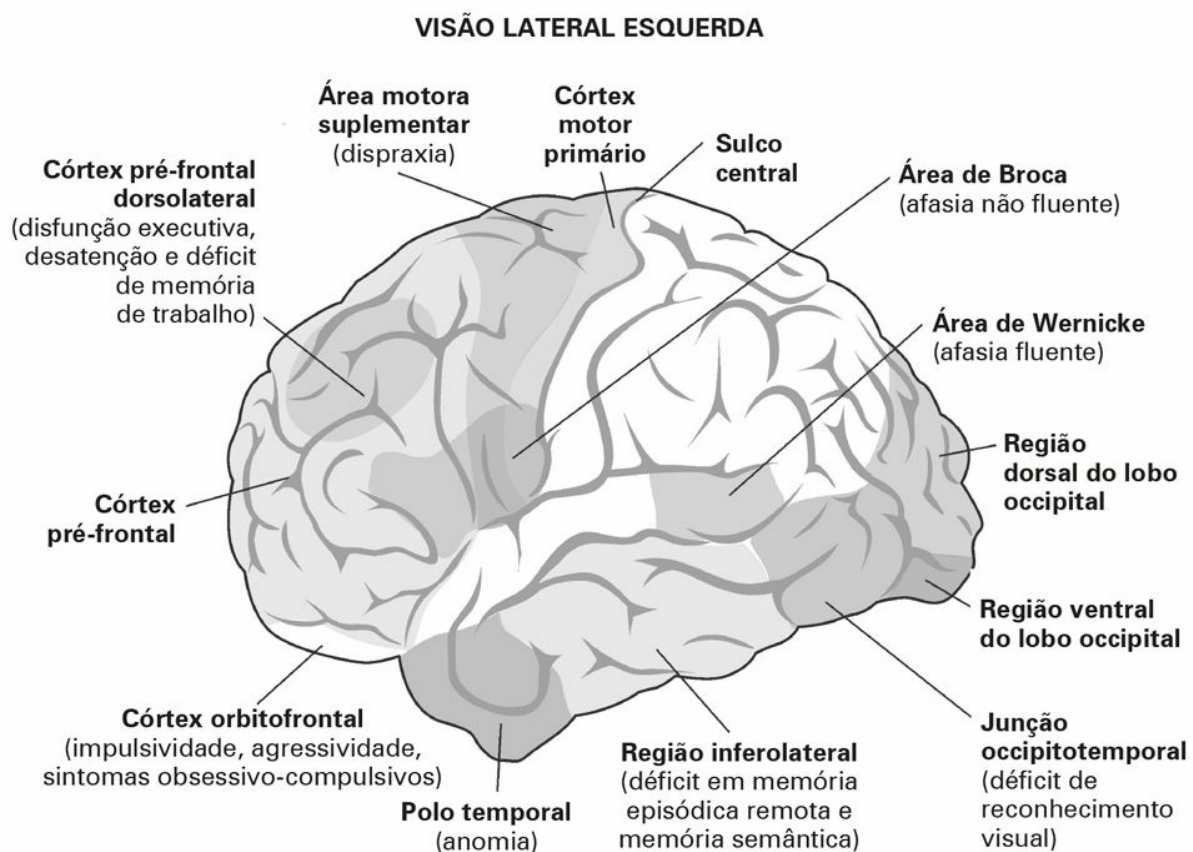
Listar todos os fármacos de uso no presente e no passado ajuda a excluir possíveis causas medicamentosas de alteração da cognição e do comportamento. Particularmente, medicamentos com ação anticolinérgica e sedativa, como antidepressivos tricíclicos e benzodiazepínicos, podem afetar substancialmente a cognição (ver Caps. 23 a 25).

Tendo em vista a presença de riscos genéticos para algumas doenças neurodegenerativas, é importante questionar sobre os antecedentes familiares de síndromes cognitivas, alterações de comportamento de início tardio e distúrbios do movimento.

Examinando a cognição

Identificar os domínios cognitivos mais comprometidos permite ao examinador estabelecer hipóteses diagnósticas anatômicas, ou seja, compreender quais circuitarias e regiões no sistema nervoso central (SNC) podem apresentar disfunções que resultam nos sintomas do paciente. Por sua vez, o diagnóstico anatômico contribui para a elaboração de hipóteses etiológicas, já que determinadas condições neuropatológicas acometem inicialmente regiões e estruturas específicas do SNC.⁴ Por exemplo, o declínio da memória episódica recente está associado a atrofia dos hipocampus e córtices entorrinais, localizados na região mesial dos lobos temporais, alterações anatômicas típicas dos estágios iniciais da DA.⁵

Didaticamente, a cognição pode ser dividida nos seguintes domínios, com base nas estruturas encefálicas e nos sistemas neurofuncionais de processamento: memória, linguagem, habilidades visuoespaciais, atenção, funções executivas e praxias.^{4,6} Na Figura 10.1, os domínios cognitivos são correlacionados com as regiões e circuitos do SNC subjacentes.⁷



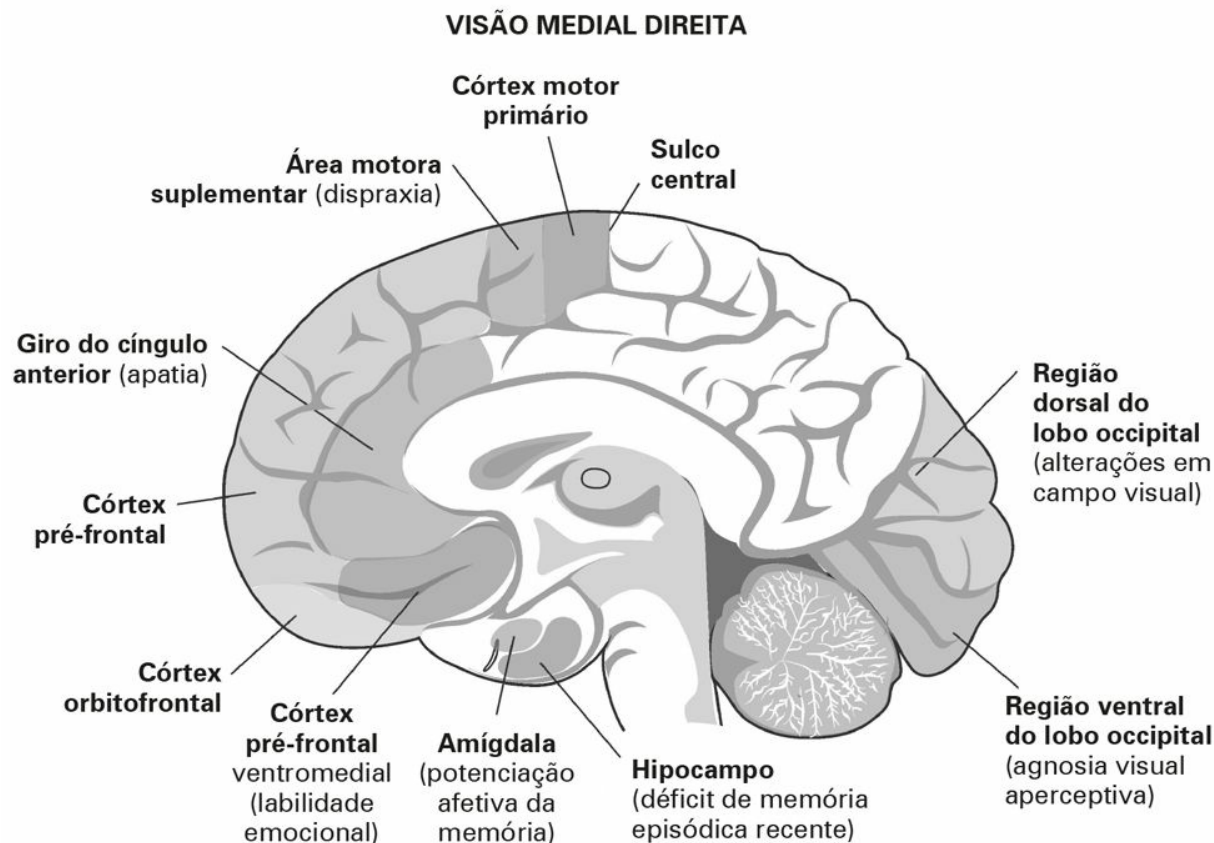


FIGURA 10.1 Regiões cerebrais e sintomas cognitivos e neuropsiquiátricos.

O Quadro 10.1 apresenta sugestões de perguntas que podem ajudar o clínico a examinar cada domínio cognitivo em particular. Contudo, o exame cognitivo é mais fluido e eficaz quando o questionamento sistematizado é adequado ao contexto sociocultural e às situações do dia a dia do paciente.

QUADRO 10.1

Acessando os domínios cognitivos

Memória

- **Episódica recente**
Verifique se o paciente se recorda, e com qual detalhamento, de notícias recentes, das últimas refeições, dos últimos episódios de programas de TV. Questione se o paciente tem se esquecido de onde guarda seus pertences, de compromissos, de pagar as contas, de comprar o necessário no mercado. Verifique se ele tem dificuldade para registrar conversas e leituras, se está mais repetitivo.
- **Episódica remota**
Pergunte sobre escolas onde o paciente estudou, nome de professores marcantes, de antigos namorados, cidades onde morou, empregos do passado, local da lua-de-mel, viagens, etc.
- **Semântica**
Questione sobre o significado de determinadas palavras; mostre-as ao paciente e pergunte seu significado. Verifique conhecimentos gerais e fatos históricos. O paciente frequentemente apresenta discurso vazio, com uso de palavras genéricas.
- **De trabalho**
Verifique se o paciente esquece o fogão ligado, as panelas no fogo, o que planejou pegar no armário, o número de telefone que acabou de verificar para discar. Peça ao paciente que repita uma sequência em ordem direta e inversa.
- **Procedural**
Indague sobre dificuldades do paciente em andar de bicicleta, dirigir, escrever, usar talheres, manusear ferramentas e utensílios de cozinha.

Linguagem

- **Afasia fluente**
Questione se o paciente está compreendendo conversas. Observe discursos vazios, com circunlóquios, vocabulário com parafrases semânticas (p. ex., dizer “chefe” do Brasil em vez de “presidente” do Brasil). Teste o paciente, solicitando que siga instruções (p. ex., “pegue na sua orelha esquerda com sua mão direita”).
- **Afasia não fluente**
Verifique se há hesitação da fala, disprosódia (perda de entonação), erros fonêmicos e sintáticos da linguagem, parafrases fonêmicas (p. ex., dizer “sefalote” em vez de “elefante”). Teste se o paciente apresenta dificuldade em repetir frases (p. ex., nem aqui, nem ali, nem lá).
- **Anomia**
Observe se o paciente tem dificuldade em nomear objetos, lugares, pessoas (fenômeno “ponta da língua”).

Habilidades visuoespaciais

Questione o paciente sobre dificuldades de reconhecimento visual de lugares (desorientação espacial) e faces (prosopagnosia). Teste se o paciente tem dificuldades de leitura (alexia), em copiar um desenho (p. ex., pentágonos interceptados, um cubo).

Atenção

Déficits de atenção podem cursar com sintomas semelhantes aos de déficit de memória de trabalho, como esquecer torneiras abertas, gás ligado, etc. Teste o paciente, solicitando que calcule séries de subtrações (100 - 7; 40 - 4; 20 - 2), que diga os meses do ano de trás para a frente.

Funções executivas

Pergunte ao paciente sobre dificuldades em lavar louças, cozinhar, calcular troco, usar caixa eletrônico, vestir-se, tomar banho. Teste a capacidade de julgamento (como noções de perigo, de conduta social) e de abstração (interpretação de provérbios, similaridade e diferenças).

Praxia

Verifique se o paciente tem dificuldades em escrever uma sentença, desenhar, assinar documentos, dirigir, caminhar, digitar, usar talheres, escovar os dentes, acenar adeus, pentear o cabelo, etc.

Memória: refere-se à capacidade de codificação, registro e evocação de conteúdos da experiência do indivíduo. Divide-se em memória episódica, semântica, de trabalho e procedural. A **memória episódica** engloba os registros autobiográficos, que são separados em fatos recentes (horas, dias e meses) e fatos remotos (meses e anos). Os hipocampus e os córtices entorrinais são responsáveis pelo processamento da memória episódica recente, enquanto regiões inferolaterais dos lobos temporais estão relacionadas à memória episódica para fatos remotos. A **memória semântica** refere-se à aprendizagem de informações sobre o mundo, incluindo-se conhecimentos gerais, conceitos para entidades básicas, significado de situações e de vivências e vocabulário. Dessa forma, é um componente fundamental dos aspectos semânticos da linguagem. Seu processamento envolve regiões inferolaterais e os polos dos lobos temporais. A **memória de trabalho** é processada pelos córtices pré-frontais dorsolaterais e consiste no registro imediato (segundos a minutos) e temporário de informações que são úteis na execução de determinada tarefa pelo indivíduo. Por fim, a **memória procedural** indica a aprendizagem de habilidades motoras complexas, que se consolidam e se automatizam. Seu processamento neurofuncional acontece nos núcleos da base e no cerebelo.

Linguagem: os déficits de linguagem são chamados de afasias e podem ser classificados em afasia fluente e não fluente. A **afasia fluente** consiste na dificuldade de entendimento do conteúdo da linguagem, do significado das palavras ou dos sinais recebidos. Embora a fala seja fluente, apresenta parafrases semânticas, discurso com circunlóquios, empobrecimento do vocabulário e tendência ao mutismo. Na afasia fluente, há prejuízo do processamento semântico da linguagem, que também pode envolver a memória semântica. O polo temporal esquerdo e a área de Wernicke são as regiões comumente afetadas. Déficits na produção fonêmica e sintática das frases são as características centrais da **afasia não fluente**, também chamada de afasia motora. Podem ocorrer parafrases fonêmicas, hesitação no início da fala e disprosódia. O córtex frontal posteroinferior esquerdo (área de Broca) está relacionado com a afasia não fluente. A dificuldade na evocação de uma palavra para uma determinada entidade é chamada de **anomia**, ou disnomia, e envolve o polo temporal esquerdo. Comumente, as patologias que afetam a

linguagem cursam com envolvimento preponderante de um dos seus subdomínios, mas também com alterações concomitantes dos outros. Por exemplo, o paciente pode apresentar alterações proeminentes da semântica e evoluir, adicionalmente, com afasia motora.

Habilidades visuoespaciais: são relacionadas às circuitarias dos lobos occipitais e englobam as capacidades de memória visual, gnosia, ou percepção visual, e organização do campo visual. A memória visual é processada pela região da junção occipitotemporal e refere-se ao registro de imagens, por exemplo, de faces e locais. Disfunções nas regiões ventrais dos lobos occipitais podem manifestar-se com agnosia visual aperceptiva, ou seja, incapacidade de identificar visualmente objetos, desenhos, letras e símbolos. Alterações do campo visual desenvolvem-se por disfunção das regiões dorsais dos lobos occipitais.

Atenção: envolve as capacidades de concentrar-se em um estímulo (tenacidade), de monitorar os variados estímulos do ambiente (vigilância) ou ambos (prosexia). Circuitarias de conexão com o córtex pré-frontal dorsolateral estão associadas com o processamento da atenção. Déficits atencionais podem afetar outros domínios cognitivos, como a memória, de modo que é fundamental considerar o comprometimento da atenção quando avaliações cognitivas mostram múltiplos domínios afetados. Alterações do humor e da ansiedade frequentemente cursam com declínio na atenção.

Funções executivas: também são processadas por circuitarias do córtex pré-frontal dorsolateral e englobam planejamento, organização e monitoramento de ideias, comportamentos e ações. Envolve também habilidades de pensamento abstrato, cálculo e julgamento. Com frequência, os pacientes com comprometimento das funções executivas podem deixar de executar atividades antes rotineiras diante de dificuldades, podem ficar mais desorganizados e não conseguir executar as tarefas com a mesma qualidade de antes e/ou podem despende mais tempo e esforço cognitivo em trabalhos simples.

Praxia: refere-se ao planejamento de atividades motoras complexas, como desenhar, escrever, dirigir, usar talheres, costurar, usar ferramentas, praticar esportes, etc. Relaciona-se principalmente ao córtex motor associativo, mas também a outras estruturas de regulação da precisão, da coordenação e da aprendizagem dos movimentos, como núcleos da base e cerebelo.

Orientação: não foram determinados, até o momento, correlatos bem definidos de sistemas específicos de processamento da capacidade de orientação. Admite-se que esse domínio cognitivo dependa de outras funções cognitivas primárias. Assim, a memória episódica recente é determinante para a orientação temporal, e as habilidades visuoespaciais, para a orientação espacial. A memória autobiográfica influencia na orientação autopsíquica.

Testes cognitivos de rastreio podem ajudar significativamente no exame da cognição, quantificando o desempenho cognitivo global do paciente e também colaborando na avaliação de domínios cognitivos específicos. Entretanto, deve-se ter cautela na interpretação de resultados transversais dos testes cognitivos, uma vez que não refletem o declínio cognitivo ao longo do tempo e não podem estimar o desempenho cognitivo de base do paciente. É fundamental que sejam considerados como complementares à anamnese, e não como uma medida absoluta ou suficiente da cognição. Além disso, é prudente lembrar de possíveis vieses durante a aplicação,

como ansiedade, sonolência, cansaço e *delirium*.⁸ A seguir, apresentam-se testes de uso frequente e cuja aplicabilidade é adequada ao contexto da interconsulta psiquiátrica.

- **Minixame do Estado Mental (MEEM):** é um teste desenvolvido em 1975 e tradicionalmente usado na avaliação diagnóstica e no acompanhamento de pacientes com demência. É de fácil e rápida aplicação, e os domínios cognitivos avaliados são: orientação temporal e espacial, memória imediata (de trabalho), atenção, evocação (memória episódica), linguagem, habilidades visuoespaciais e praxia.⁹ Os pontos de corte variam muito de acordo com a idade e a escolaridade da população, bem como entre os estudos de validação. O MEEM foi validado no Brasil por Bertolucci e colaboradores.¹⁰ Os pontos de corte estabelecidos para a população brasileira são: analfabetos, 20; sujeitos com escolaridade de 1 a 4 anos, 25; de 5 a 8 anos, 26,5; de 9 a 11 anos, 28; e ≥ 12 anos, 29.^{11,12} Como não avalia as funções executivas, o MEEM pode não ter boa acurácia para o comprometimento cognitivo secundário à doença cerebrovascular de pequenos vasos, à demência na doença de Parkinson, à demência por corpúsculos de Lewy e à demência frontotemporal, particularmente, em estágios iniciais.¹³⁻¹⁶ Além disso, não é uma boa ferramenta para avaliar pacientes com escolaridade elevada e condições pré-demenciais, já que é uma medida superficial da cognição, podendo apresentar resultados falsos-negativos nesses contextos. Veja o MEEM no fim deste capítulo (Anexo 1).⁸
- **Teste do Desenho do Relógio (TDR):** solicita-se ao paciente que desenhe um relógio, iniciando pelo contorno, em seguida colocando todos os números e, por fim, marcando, com os ponteiros, um horário determinado (p. ex., 11 horas e 10 minutos). Um dos métodos de correção consiste em pontuar 0 ou 1 para cada tarefa, totalizando-se 3 pontos: 1 ponto para o contorno, 1 ponto para a sequência e a disposição correta dos números e 1 ponto para a marcação correta do horário com os ponteiros.¹⁷ É um teste que avalia principalmente praxia (desenho do círculo e dos ponteiros e escrita dos números) e funções executivas (sequência e disposição corretas dos números e abstração na marcação do horário com os ponteiros dos minutos).^{8,17} Para uma testagem cognitiva mínima e rápida, sugere-se o MEEM juntamente com o TDR, já que o TDR complementa o MEEM por melhor avaliar funções executivas, rastreando-se, assim, os principais domínios cognitivos.¹⁸
- **Montreal Cognitive Assessment (MoCA):** trata-se de um teste de rastreio cognitivo e de rápida aplicação (cerca de 10 minutos). A pontuação varia de 0 a 30, e o valor de corte da normalidade é maior ou igual a 26, de acordo com a versão brasileira. Suas vantagens sobre o MEEM são a abrangência dos principais domínios cognitivos e melhor acurácia na discriminação entre indivíduos sadios e com comprometimento cognitivo leve (CCL). A escolaridade acaba sendo um importante viés desse instrumento, uma vez que domínios cognitivos influenciados pela educação formal, como fluência verbal e abstração, têm peso importante na nota final.^{8,19,20} Ao fim deste capítulo, disponibilizamos a versão brasileira do MoCA (Anexo 2).^[INT]
- **Fluência verbal:** conta-se o número de palavras que o paciente é capaz de dizer em 1 minuto, a partir de uma categoria semântica (p. ex., animais, ferramentas ou frutas) ou de uma categoria fonêmica (p. ex., palavras que começam com as letras F, A ou S). Não se consideram nomes próprios (p. ex., de pessoas ou cidades) e sequência de palavras derivadas

(como fogo e fogueira, ou sabor, saboroso e saborear). É um teste que pode ser usado para avaliar a linguagem (semântica e fonêmica), mas também é influenciado pelas funções executivas, uma vez que sua execução envolve uma tarefa cognitiva de seleção de palavras de acordo com uma lógica abstrata.⁸ A escolaridade pode afetar o desempenho na fluência verbal, tendo em vista que o teste está associado diretamente com o vocabulário e a capacidade de abstração do indivíduo.²¹ Por isso, embora possa ser utilizado no rastreio cognitivo rápido por meio de uma interpretação qualitativa, uma análise quantitativa precisa basear-se em dados normativos validados, considerando-se a idade e a escolaridade do paciente.

Avaliando o comportamento: sintomas neuropsiquiátricos

Provavelmente, a principal demanda por interconsulta psiquiátrica de pacientes idosos é devida a alterações de comportamento no pronto-socorro ou durante uma internação clínica ou cirúrgica. As alterações de comportamento no contexto das patologias neurodegenerativas e cerebrovasculares são chamadas atualmente de sintomas neuropsiquiátricos (SNPs). Sintomas não cognitivos das demências, sintomas psicológicos e comportamentais e sintomas comportamentais são sinônimos que podem ser encontrados na literatura médica.²² São sintomas associados a todos os estágios do declínio cognitivo e presentes no quadro clínico de todas as patologias neurodegenerativas e cerebrovasculares.^{23,24} Eles implicam pior qualidade de vida, maior incapacidade funcional, maior velocidade de progressão do declínio cognitivo, maior frequência de institucionalização, maior sobrecarga de familiares e cuidadores e maior mortalidade.²²⁻²⁴

O Inventário Neuropsiquiátrico (NPI, em inglês) é um dos instrumentos mais usado tanto em pesquisa como na prática clínica na avaliação dos SNPs. É um instrumento preenchido pelo clínico, com base nas respostas do cuidador ou familiar que convive com o paciente.²⁵ Em 2010, ele foi revisado, desenvolvendo-se uma nova versão, chamada Inventário Neuropsiquiátrico – Escala de Avaliação do Clínico (NPI-C, em inglês). O NPI-C também considera a entrevista com o paciente e a impressão clínica do avaliador, evitando vieses relacionados a informações exclusivas do cuidador. Além disso, a nova versão revisou os domínios neuropsiquiátricos, com o objetivo de melhorar a confiabilidade, aprofundar a avaliação de cada domínio e refinar a descrição de sintomas frequentes em estágios graves da demência. Dessa forma, o NPI-C estabelece os seguintes domínios neuropsiquiátricos: delírios, alucinações, agitação, agressividade, depressão/disforia, ansiedade, euforia/euforia, apatia/indiferença, desinibição, irritabilidade/labilidade, distúrbio motor aberrante, distúrbios do sono, distúrbios do apetite e da alimentação e vocalizações aberrantes.²⁴ O NPI-C foi traduzido e validado para a população brasileira, e seu uso está disponível.²⁶

Na prática clínica, além da descrição dos sintomas, a avaliação neuropsiquiátrica de idosos envolve também elencar possíveis fatores etiológicos e/ou desencadeantes. Assim, alterações de comportamento podem surgir devido à reação psicológica compreensível ao envelhecimento, ao adoecimento, ao declínio cognitivo e funcional; às alterações psicopatológicas de transtornos psiquiátricos primários; à disfunção de circuitarias neuronais, responsáveis pela regulação do

comportamento; e à má adaptação comportamental a estressores externos e internos em pacientes com demência.^{22,23,27}

Com frequência, sintomas depressivos e ansiosos de leve intensidade podem aparecer no contexto de reações de ajustamento em pacientes cognitivamente preservados, com CCL ou com demência leve. Idosos internados também podem sofrer descompensações de transtornos psiquiátricos de início na juventude ou vida adulta, como transtorno depressivo recorrente, transtornos de ansiedade, transtorno bipolar, esquizofrenia e transtornos da personalidade. Estressores físicos e psicossociais associados à internação podem desencadear e/ou agravar reações psicológicas ou sintomas psiquiátricos primários de base.²³ Outros capítulos deste livro abordam mais extensamente o diagnóstico e o manejo dos transtornos psiquiátricos primários e das reações psicológicas à doença e à hospitalização.

Circuitos cerebrais relacionados à regulação do comportamento podem ser diretamente afetados por patologias neurodegenerativas e cerebrovasculares, levando ao aparecimento de SNPs. Dessa forma, sabe-se que alterações em circuitos do cíngulo anterior estão associadas à apatia. Agressividade, impulsividade, desinibição social e sexual e comportamento estereotipado são sintomas relacionados a disfunções do córtex pré-frontal orbitofrontal. Labilidade afetiva, depressão e euforia podem aparecer por alterações do córtex pré-frontal ventromedial. Disfunções de circuitarias na região parieto-occipital podem cursar com alucinações e ilusões visuais.⁴

Má adaptação cognitiva e comportamental a estressores internos e externos é o contexto mais frequente de aparecimento de SNPs em idosos com demência internados no hospital geral, ocorrendo principalmente em estágios mais avançados das demências.

Agitação, agressividade, vocalizações aberrantes, ansiedade, distúrbios do sono, depressão e apatia são respostas comportamentais indicativas de desconforto e sofrimento físico e/ou emocional. A hospitalização pode estar associada a vários desencadeantes de SNPs, como mudança de ambiente e de rotina, alternância frequente da equipe de enfermagem, falta de estímulos, excesso de ruídos, desconforto com acessos e cateteres, restrição ao leito, dor, infecção, desidratação, distúrbios eletrolíticos, cirurgias e efeitos adversos de medicamentos.^{23,27}

A descrição abrangente e minuciosa dos SNPs e a investigação extensiva de possíveis causas são fundamentais para se delinear seu manejo e tratamento. Assim, na avaliação neuropsiquiátrica, devem-se detalhar os domínios neuropsiquiátricos envolvidos, a intensidade e o impacto dos sintomas, o ambiente e o contexto em que aparecem e as perspectivas e expectativas do paciente, dos familiares e dos cuidadores. O passo seguinte é pesquisar possíveis desencadeantes e contribuintes para os sintomas apresentados, investigando fatores associados ao paciente, ao cuidador e ao ambiente.²⁷

O Quadro 10.2 lista exemplos de desencadeantes e contribuintes de alterações de comportamento, cuja investigação de rotina é necessária em idosos com demência. Alterações físicas comumente são responsáveis pelo quadro clínico, de forma que a avaliação deve incluir exame físico, exame neurológico e exames complementares.

QUADRO 10.2

Fatores desencadeantes e contribuintes de sintomas neuropsiquiátricos nas demências e sugestões de manejo

Associados ao paciente

- Mudanças recentes em medicações
- Dor
- Exposição a tarefas que o paciente é incapaz de realizar
- Medo e insegurança (p. ex., medo de ficar sozinho)
- Ócio, tédio
- Condições médicas gerais (p. ex., infecção urinária, desidratação, constipação)
- Comorbidades psiquiátricas primárias (p. ex., transtornos do humor, transtornos da personalidade)
- Higiene do sono ruim
- Perdas sensoriais (audição, visão)

Associados ao cuidador

- Desconhecimento sobre demência (p. ex., acreditando que o paciente “faz de propósito”)
- Comunicação áspera e pouco direta (com muitas perguntas e oferecendo muitas alternativas ao paciente)
- Expectativas incoerentes com o estágio do declínio cognitivo (estímulos e exigências estão além ou aquém das capacidades do paciente)
- Sobrecarga e sintomas depressivos dos cuidadores
- Influências familiares e culturais (p. ex., filhos de pais com demência podem acreditar que os estão abandonando ao contratar cuidadores ou ao levá-los para uma instituição especializada)

Associados ao ambiente

- Excesso de estímulos (barulho, muitas pessoas, bagunça)
- Falta de estímulos (baixa iluminação, silêncio)
- Falta de pistas visuais (calendários, relógio, fotografias)
- Mudanças frequentes de ambiente (p. ex., o paciente idoso pode ficar cada dia na casa de um filho)
- Falta de rotina
- Dificil acessibilidade (escadas, falta de barras de auxílio)
- Falta de atividades prazerosas e adequadas às capacidades cognitivas e aos interesses prévios do paciente

Sugestões de manejo

- Reavaliar medicações que possam afetar a cognição e o comportamento
- Investigar e tratar dores e outras condições físicas
- Otimizar o tratamento para condições psiquiátricas primárias
- Implementar medidas de higiene do sono
- Adequar óculos e aparelhos auditivos
- Orientar familiares e cuidadores sobre demência, alterações do comportamento e suas causas de base
- Sugerir revezamento de cuidadores
- Oferecer suporte psicológico e familiares e cuidadores
- Adequar a comunicação (frases simples e diretas, fala calma e tranquilizadora, ajuda para encontrar palavras para se expressar e para identificar pessoas que não reconheceu)
- Proporcionar ambiente seguro e acessível
- Equilibrar estímulos, adequando-os às capacidades e aos interesses do paciente

Fonte: Com base em Kales e colaboradores.²⁷

Funcionalidade

O declínio cognitivo e neuropsiquiátrico subtrai progressivamente as capacidades do sujeito, desde as mais complexas até as mais simples. Déficits cognitivos leves podem causar apenas impacto funcional leve, sem maiores prejuízos. Particularmente, pacientes com elevada reserva cognitiva podem contornar o déficit cognitivo por meio de estratégias adaptativas, de modo a preservar a funcionalidade e dificultar o diagnóstico.²⁸ Em contrapartida, déficits cognitivos graves implicam incapacidade funcional com perda de autonomia, dependência de cuidadores e pior qualidade de vida.²⁹

A funcionalidade pode ser dividida em atividades instrumentais da vida diária (AIVDs) e atividades básicas da vida diária (ABVDs). As AIVDs correspondem a tarefas de maior

dificuldade cognitiva, como cuidar das próprias finanças, arrumar e fazer pequenos reparos na casa, usar o telefone, preparar uma refeição para si mesmo, fazer compras, tomar corretamente os medicamentos e locomover-se fora de casa de forma independente. As ABVDs referem-se ao autocuidado, como vestir-se, tomar banho, alimentar-se, fazer a higiene pessoal, controlar esfíncteres, sentar-se, levantar-se e deitar-se sem a necessidade de ajuda.³⁰

O Questionário de Atividades Funcionais de Pfeffer e o Functional Assessment Staging (FAST) são instrumentos úteis para a mensuração da funcionalidade na prática clínica. O Pfeffer (Anexo 3) contém perguntas direcionadas ao familiar ou cuidador, que avaliam as AIVDs. Dessa forma, seu uso contribui para o diagnóstico e é adequado para a caracterização dos estágios iniciais do declínio cognitivo. Por sua vez, o FAST contempla todos os níveis de declínio funcional, detalhando as perdas de ABVDs em estágios mais graves de demência.^{31,32}

Exame físico e neurológico

Todo idoso com sintomas cognitivos e comportamentais deve ser submetido a exame físico e neurológico. Por meio do exame físico, causas sistêmicas de distúrbios cognitivos e neuropsiquiátricos já podem ser identificadas, como insuficiência orgânica (cardíaca, respiratória, renal e hepática), desnutrição, infecções, instabilidade hemodinâmica e arritmias. O exame neurológico é essencial para avaliar alterações motoras, sinais de lateralização, dispraxias, sinais extrapiramidais, alterações de força, marcha e equilíbrio e presença de reflexos primitivos (ver Cap. 9), que podem apontar para determinadas patologias. Para uma descrição completa dos exames físico e neurológico, indicamos consultar livros específicos.^{33,34}

Estadiamento

As definições mais recentes e mais usadas na literatura estabelecem quatro estágios de declínio cognitivo, neuropsiquiátrico e funcional, a partir do nível de desempenho anteriormente atingido pelo indivíduo: normalidade, declínio cognitivo subjetivo, comprometimento cognitivo leve e demência (Fig. 10.2).²⁹ O *Manual diagnóstico e estatístico de transtornos mentais* (DSM-5) classifica as síndromes cognitivas em transtorno neurocognitivo maior (cujos critérios correspondem à demência) e em transtorno neurocognitivo leve (correspondente ao CCL), mas essa nomenclatura não tem sido, ainda, utilizada com frequência na literatura médica e no meio clínico.³⁵

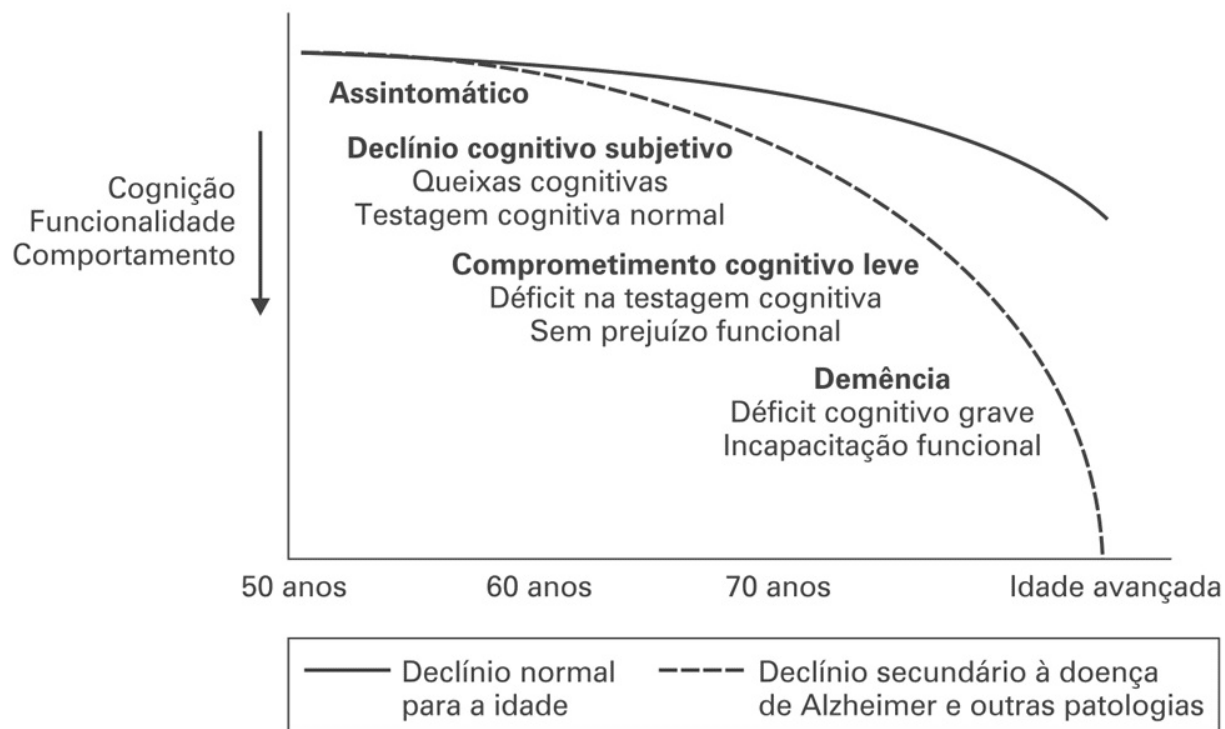


FIGURA 10.2 Estadiamento do declínio cognitivo.

Idosos saudáveis são aqueles que não apresentam queixas cognitivas significativas e consistentes, têm desempenho em testes cognitivos dentro do esperado para idade e escolaridade e não têm prejuízo na funcionalidade em consequência da cognição. É esperado que o envelhecimento normal seja acompanhado de declínio cognitivo (principalmente da velocidade de processamento e execução), mas ele não altera as testagens objetivas (calibradas para a idade) e não compromete as capacidades do sujeito.^{6,8} No entanto, a fisiopatologia da DA e de outras condições neurodegenerativas já pode estar em curso em indivíduos assintomáticos.³⁶

O declínio cognitivo subjetivo refere-se aos pacientes com queixa cognitiva significativa e consistente, mas que apresentam resultados normais nos testes cognitivos objetivos e não apresentam declínio funcional. Antes visto equivocadamente como “esquecimento benigno”, estudos recentes apontam que o declínio cognitivo subjetivo implica maior risco de evolução para demência, em comparação à população em geral.²⁸

O estágio subsequente é o CCL, no qual os resultados da testagem cognitiva objetiva evidenciam déficits, mas a funcionalidade e a independência em todas as atividades da vida estão preservadas. O risco de conversão para demência é alto nesse estágio, principalmente quando associado a idade avançada, déficit em memória episódica recente, SNPs (particularmente depressão, apatia e alterações do sono) e biomarcadores de doenças neurodegenerativas (como atrofia hipocampal, no caso da DA).³⁷

Demência é definida pela presença de déficits cognitivos graves e consequente incapacidade funcional. Na maioria das vezes, há um limite claro entre normalidade e declínio cognitivo.³⁸

A **Clinical Dementia Rating (CDR)** e a **Global Deterioration Scale (GDS)** são instrumentos tradicionalmente usados para o estadiamento do declínio cognitivo.^{6,29}

EXAMES COMPLEMENTARES

Os exames complementares têm por objetivo aprofundar o exame cognitivo e neuropsiquiátrico, excluir causas reversíveis de alterações da cognição e do comportamento e ajudar no diagnóstico diferencial da etiologia subjacente.

Avaliação neuropsicológica

Trata-se da aplicação de testes cognitivos e instrumentos de avaliação do comportamento e da funcionalidade por neuropsicólogos. A avaliação neuropsicológica obtém dados quantitativos e qualitativos acerca do desempenho cognitivo do paciente, comparando com a média esperada para sua idade e escolaridade. Os resultados definem a presença ou ausência de déficit cognitivo de forma objetiva e quais os domínios cognitivos mais afetados, colaborando principalmente para o diagnóstico dos estágios iniciais do declínio cognitivo e para a investigação da(s) patologia(s) de base.

Exames laboratoriais

Os exames laboratoriais de rotina são fundamentais para se avaliar possíveis alterações sistêmicas que podem afetar a cognição e o comportamento, como anemia, déficit vitamínico, distúrbios tireoidianos, insuficiência orgânica, distúrbios hidreletrolíticos, alterações metabólicas e infecções (urinária, HIV, sífilis).

A depender da situação clínica, exames específicos podem ser necessários. Por exemplo, hemoglobina glicada em diabéticos, urocultura na infecção urinária, hemocultura em infecções sistêmicas, carga viral e CD4/CD8 em portadores de HIV, nível sérico de medicamentos e drogas em intoxicações exógenas.

Neuroimagem

Os exames de neuroimagem estrutural, ou seja, tomografia computadorizada (TC) ou ressonância magnética (RM), são imprescindíveis para a avaliação dos sintomas cognitivos e neuropsiquiátricos. Além de excluírem alterações grosseiras de condições não degenerativas do SNC (neoplasias, encefalites, lesões macrovasculares), as neuroimagens evidenciam alterações que estão fortemente associadas a determinadas patologias, de modo a serem caracterizadas como biomarcadores de doenças neurodegenerativas e cerebrovasculares. Por exemplo, atrofia dos hipocampus está relacionada à DA, e hiperintensidades em substância branca nas sequências T2 e FLAIR (do inglês, *fluid liquid attenuation inversion recovery*) da RM sugerem microangiopatia. Ademais, correlacionar os achados da neuroimagem com a avaliação clínica é a base do diagnóstico diferencial dos transtornos cognitivos e comportamentais.^{39,40}

Atrofia cortical e microangiopatia subcortical podem ocorrer no envelhecimento normal. Assim, a suspeita de doenças neurodegenerativas e cerebrovasculares parte de evidências de

atrofia ou microangiopatia maiores do que o esperado para a idade.

Ademais, não é raro se deparar com situações em que pacientes cognitivamente preservados apresentam atrofia cortical ou lesões cerebrovasculares significativas, ou pacientes com franco declínio cognitivo que mostram RM normal para a idade. Diferentes reservas cognitivas podem explicar essa dissociação clínico-radiológica. Reserva cognitiva elevada implica a preservação cognitiva por mais tempo, mesmo diante de atrofia e lesões cerebrais patológicas. Contudo, baixa reserva cognitiva está associada a declínio cognitivo em pacientes com SNC anatomicamente normal, podendo apresentar apenas alterações funcionais. Assim, para se evitar diagnósticos equivocados, a solicitação das neuroimagens deve partir de suspeitas clínicas bem estabelecidas, e sua interpretação deve estar correlacionada com a sintomatologia e a reserva cognitiva.³⁹⁻⁴³

O Quadro 10.3 descreve as técnicas mais frequentemente usadas e os principais achados de RM na avaliação do declínio cognitivo.

QUADRO 10.3

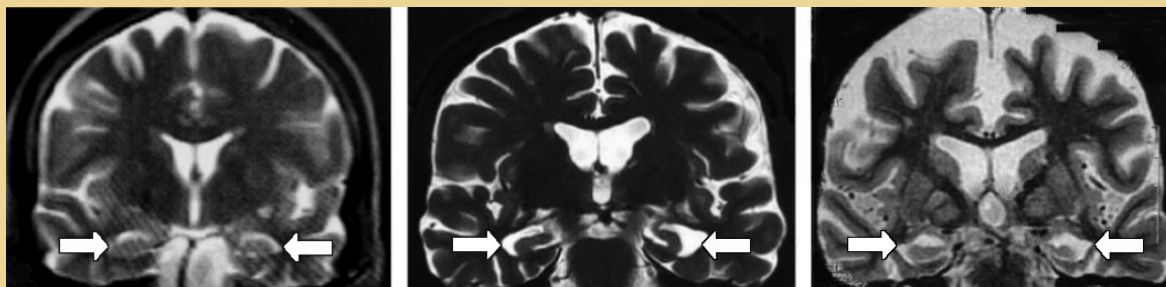
Ressonância magnética no declínio cognitivo

As técnicas de RM utilizadas atualmente permitem visualizar de forma detalhada as estruturas corticais e subcorticais, aumentando a sensibilidade do diagnóstico das doenças neurodegenerativas e cerebrovasculares.

As sequências ponderadas em T1 mostram o LCS em preto e destacam o contraste entre substância cinzenta e branca. Fornecem detalhes anatômicos, favorecendo a identificação de atrofia cortical. Sequências ponderadas em T2 apresentam o LCS brilhante e proporcionam excelente contraste entre tecido cerebral normal e patológico. FLAIR é uma sequência variante de T2, em que se anula o sinal da água, de modo que o LCS aparece em preto. Nessa sequência, lesões periventriculares e subcorticais são mais facilmente detectadas, como, por exemplo, hiperintensidades puntiformes e/ou confluentes em substância branca associadas a microangiopatia.⁴¹

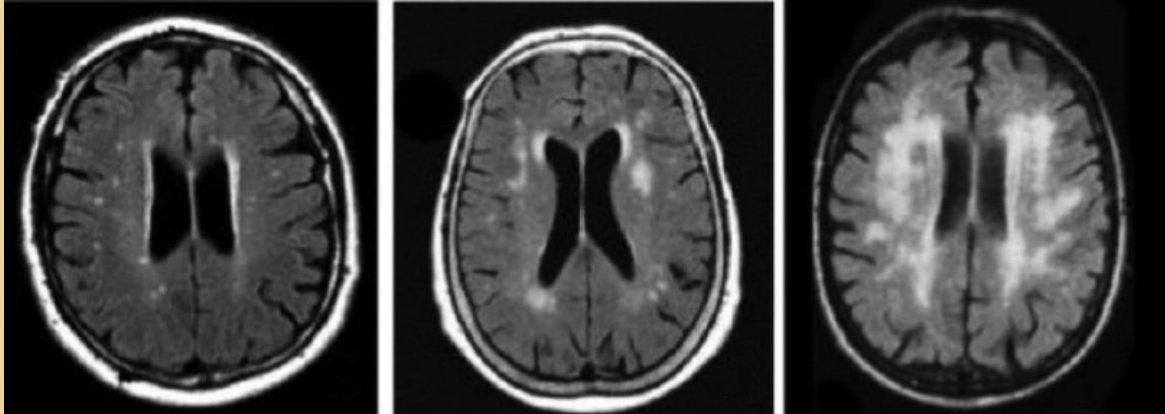
Para auxiliar na avaliação dos principais achados de RM associados às patologias cognitivas mais frequentes, sugerimos a escala visual de Duara & Scheltens (2013),⁴³ que estadia a atrofia dos hipocampos e córtices entorrinais de zero a 4, com base em cortes coronais, e a escala de Fazekas *et al* (2001),⁴² que classifica a presença de lesões associadas à microangiopatia de zero a 3, a partir de cortes axiais.^{42,43}

Escala de Duara & Scheltens



Sequências em T2 de pacientes diferentes, ilustrando os hipocampos (setas). A imagem (A) mostra atrofia de grau 1 de ambos os hipocampos; em (B) há atrofia grau 2 no hipocampo à direita e grau 3 à esquerda; na imagem (C) vemos atrofia grau 3 à direita e grau 4 à esquerda.

Escala de Fazekas



RM-FLAIR mostra hiperintensidades em substância branca periventricular e subcortical e em núcleos da base, que estão associadas a alterações microangiopáticas. Grau 1: uma ou mais lesões puntiformes esparsas; grau 2: lesões começam a se confluir; e grau 3: lesões confluentes tomam regiões inteiras (leucoaraiose).

Os exames de medicina nuclear tomografia computadorizada por emissão de fóton único (SPECT) e tomografia computadorizada por emissão de pósitrons (PET) são as principais técnicas de neuroimagem funcional usadas na prática clínica. A SPECT mostra a perfusão das regiões do SNC, parâmetro relacionado ao metabolismo cerebral. A PET com traçador para glicose (FDG, *F-18 Fluorodeoxyglucose*) evidencia o consumo de glicose pelos neurônios e está associada mais diretamente ao metabolismo cerebral. Hipoperfusão na SPECT e/ou hipometabolismo na FDG-PET de determinadas regiões apontam para patologias específicas.^{39,44}

Outros traçadores estão sendo testados e usados na prática clínica. Já em uso, o TRODAT-1 com SPECT marca o transportador de dopamina (DAT, em inglês), cuja redução nos núcleos da base está relacionada às doenças de Parkinson e de Lewy.⁴⁵ O PiB-PET (Pittsburgh Compound B) evidencia o depósito de peptídeo β -amiloide no SNC e tem sido testado como biomarcador da DA.^{5,36,38} A RM funcional é outra técnica de neuroimagem funcional, mais utilizada em pesquisa do que na rotina clínica.³⁹

Líquido cerebrospinal

A análise geral do líquido cerebrospinal (LCS) (bioquímica, citologia, imunologia e microbiologia) é necessária quando se suspeita de infecções, neoplasias ou doenças inflamatórias do SNC. Mais recentemente, a diminuição do peptídeo β -amiloide e o aumento da proteína Tau (total e fosforilada) no LCS foram associados com a DA, figurando como biomarcadores e colaborando com o diagnóstico em situações especiais.^{5,36,38}

Testes genéticos

Em casos específicos, a genotipagem de determinadas proteínas pode ajudar na prática clínica. A apolipoproteína E (APOE) age no *clearance* dos peptídeos amiloides do SNC, tendo importante papel na DA. O polimorfismo com dois alelos $\epsilon 4$ da APOE aumenta o risco de DA em aproximadamente 12 vezes, enquanto a presença de um alelo $\epsilon 2$ reduz o risco em 2 vezes, e o alelo $\epsilon 3$ é neutro.⁴⁶ Genes da pré-senilina 1 (PSEN1), da pré-senilina 2 (PSEN2) e da proteína

precursora de amiloide (APP, *amyloid precursor protein*) estão associados à DA familiar (discutidos mais adiante neste capítulo).⁴⁷ CADASIL (*Cerebral autosomal dominant arteriopathy with subcortical infarcts and leukoencephalopathy*) e degeneração lobar frontotemporal são outras condições em que testes genéticos podem contribuir para o diagnóstico.^{13,14,48}

O Quadro 10.4 apresenta uma sugestão de exames a serem solicitados na rotina da avaliação de pacientes com sintomas cognitivos e neuropsiquiátricos.

QUADRO 10.4

Sugestão de exames para avaliação de rotina de sintomas cognitivos e neuropsiquiátricos

- Hemograma
- TSH (hormônio tireoestimulante)
- T4 livre
- Vitamina B12
- Vitamina D
- Ácido fólico
- Na
- K
- Ca
- Creatinina
- Ureia
- AST (aspartato aminotransferase)
- ALT (alanina aminotransferase)
- CPK (creatinafosfoquinase)
- Bilirrubinas
- Colesterol total e frações
- Triglicérides
- Glicemia de jejum
- Sorologia para HIV
- Sorologia para hepatite B
- Sorologia para hepatite C
- Urina 1
- Urocultura
- Eletrocardiograma
- Neuroimagem estrutural (preferencialmente RM)

TRANSTORNOS COGNITIVOS E NEUROPSIQUIÁTRICOS

Delirium

É um dos principais diagnósticos diferenciais da demência. O início agudo, a relativa reversibilidade, o comprometimento da atenção e do nível de consciência e a flutuação dos sintomas ao longo do dia apontam para *delirium* (ver Cap. 14).

Idosos com demência têm maior risco de desenvolver *delirium*, de modo que essas condições frequentemente são concomitantes. No geral, os sintomas do *delirium* sobressaem aos da demência, dominando o quadro clínico. No entanto, alterações de comportamento presentes no *delirium* (agitação, alucinações visuais, delírios, labilidade emocional e agressividade) podem ser interpretadas como SNPs secundários à síndrome demencial de base. Esse equívoco pode levar ao tratamento sintomático apenas, sem a investigação dos fatores precipitantes de *delirium* (infecções, distúrbios hidreletrolíticos, dor, medicamentos), cuja abordagem é imprescindível para a resolução do quadro. Assim, investigar, com exames complementares de rotina, todo paciente com demência que desenvolver SNPs facilita o diagnóstico de *delirium* como uma das causas de alterações de comportamento. Em situações clínicas menos evidentes, o eletrencefalograma pode auxiliar, já que a presença de ondas lentas e a perda da reatividade à abertura e ao fechamento dos olhos são achados indicativos de *delirium*.⁴⁹

Doença de Alzheimer

A DA é uma condição neurodegenerativa, de início insidioso e evolução crônica, progressiva e, até o momento, irreversível. Idade e genética são os principais fatores de risco, enquanto reserva cognitiva (desempenho intelectual, educação formal e profissão) é o fator de proteção mais relevante. O início do quadro é marcado por declínio da memória episódica recente, que pode vir acompanhado de déficits em outros domínios cognitivos (comumente anomia e alterações visuoespaciais) e/ou de SNPs (depressão e apatia). Com o avançar da doença, o declínio se agrava, e mais domínios cognitivos e neuropsiquiátricos vão sendo acometidos.⁵⁰

Subjacentemente, ocorre atrofia das regiões cerebrais, iniciando-se pelos hipocampus e córtices entorrinais (responsáveis pelos déficits de memória recente) e progredindo para polos temporais (associados à anomia), região parieto-occipital (relacionada com alterações visuoespaciais) e, ao fim, todo o cérebro. Incapacidade de deambular, contraturas e disfagia aparecem na fase terminal da doença, estão associados a escaras, fraturas e pneumonias broncoaspirativas e são preditores de óbito.^{38,50}

Atualmente, a teoria fisiopatológica mais aceita para a DA é a cascata amiloide, que envolve depósito de b-amiloide no SNC, seguido de hiperfosforilação da proteína Tau, culminando com morte neuronal e atrofia cerebral. Alguns biomarcadores da fisiopatologia da DA estão acessíveis na prática clínica para auxiliar no diagnóstico. A TC ou a RM evidenciam atrofia dos hipocampus e dos córtices entorrinais (Fig. 10.3), alterações bem estudadas e fortemente

associadas a DA. Contudo, a atrofia observada na TC ou na RM é evidência tardia da doença, uma vez que a cascata amiloide deflagra o curso neurodegenerativo anos antes da sua constatação por imagem. Hipoperfusão na SPECT e/ou hipometabolismo na PET em regiões parieto-occipital e mesial dos lobos temporais também estão associados à doença (Fig. 10.3).

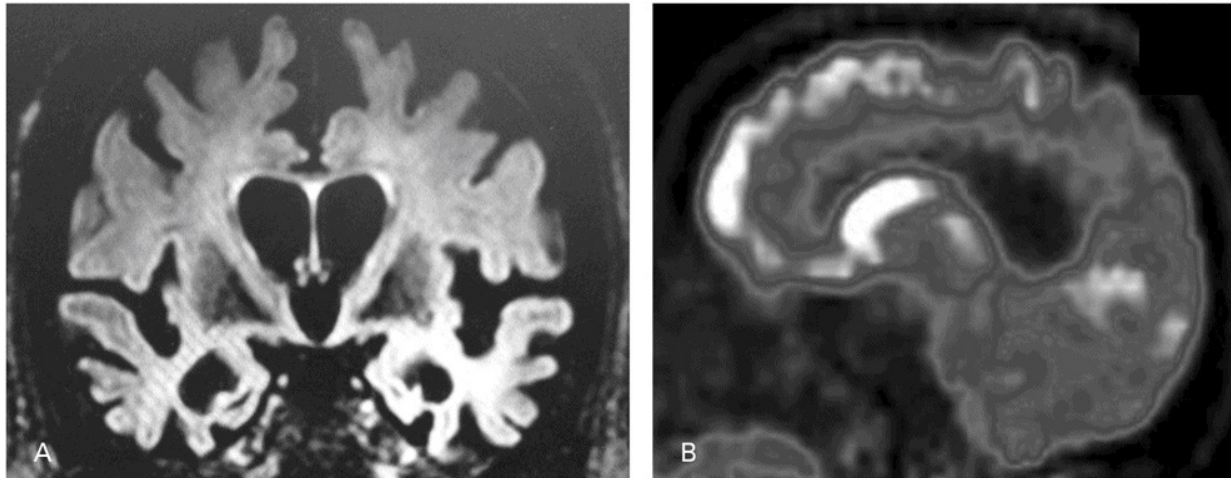


FIGURA 10.3 Mulher, 92 anos, demência grave devido a doença de Alzheimer. RM-T1 evidencia atrofia hipocampal acentuada (grau 4 de Duara & Scheltens, bilateralmente) e atrofia cortical (A). Em (B), a FDG-PET mostra hipometabolismo parieto-occipital.

Mais recentemente, estão disponíveis o PiB-PET e a dosagem de b-amiloide e proteína Tau (total e fosforilada) no LCS, biomarcadores mais específicos e que refletem alterações da cascata amiloide, eventualmente anteriores às evidências de atrofia por imagem estrutural. Eles possibilitam o diagnóstico precoce, ou seja, em estágios pré-demenciais da DA. Também, podem ajudar decisivamente no diagnóstico diferencial com outras doenças neurodegenerativas, particularmente em casos de variantes não amnésicas da DA, nas quais a memória recente não é o principal domínio cognitivo acometido e a atrofia não ocorre preferencialmente nos hipocampus. No entanto, a falta de dados normativos para a avaliação dos resultados e o elevado custo dificultam seu uso na rotina clínica.^{5,36,38}

O alelo $\epsilon 4$ da APOE está consistentemente associado a maior risco de conversão para demência na DA em idosos com CCL, com depressão, ou mesmo na população em geral. Por isso, a genotipagem da APOE tem sido frequentemente usada para o diagnóstico precoce em grupos de risco.^{5,37,38,46,50} Mutações nos genes APP, PSEN1 e PSEN2 acarretam no aumento da produção de b-amiloide e têm herança autossômica dominante. A pesquisa desses genes está indicada diante da suspeita de Alzheimer familiar, cujo quadro clínico cursa mais frequentemente com início precoce (antes dos 65 anos), sintomatologia atípica e antecedentes familiares de demência pré-senil. Em casos geneticamente confirmados, o aconselhamento genético para familiares é preconizado, mas a testagem dos familiares é eticamente questionável.⁴⁷

O tratamento farmacológico é sintomático, e seus objetivos são reduzir a velocidade de progressão clínica da doença, estabilizar o paciente em estágios mais precoces e prevenir e tratar SNPs. Inclui inibidores da colinesterase (rivastigmina, donepezila e galantamina), antagonista de receptor N-metil-D-aspartato (NMDA) (memantina) e medicamentos direcionados para SNPs

específicos. Estão em desenvolvimento novas estratégias farmacológicas, com o propósito de intervenção no curso neurobiológico da doença. O tratamento não farmacológico engloba psicoeducação de paciente, familiares e cuidadores; estimulação cognitiva; terapia ocupacional; psicoterapia e grupos de apoio para familiares e cuidadores; fisioterapia; orientação nutricional; cuidados de enfermagem; e fonoterapia.⁵⁰

Doença cerebrovascular

Alterações vasculares no SNC podem causar declínio cognitivo e SNPs. Hipertensão arterial sistêmica, diabetes melito, dislipidemia, obesidade, sedentarismo, tabagismo e etilismo são os principais fatores que contribuem para o surgimento da doença cerebrovascular. Os dois principais mecanismos fisiopatológicos envolvidos são doença de grandes vasos (AVC) e de pequenos vasos (microangiopatia).⁴⁸

Na doença de grandes vasos, a demência ocorre após múltiplos infartos cerebrais ou após único infarto estratégico (que acomete área de integração no SNC, como o tálamo). O quadro clínico, nesses casos, é de instalação subaguda e de evolução em degraus, com períodos de estabilização e de pioras diante de novos eventos vasculares. Os sintomas cognitivos e neuropsiquiátricos variam de acordo com a região afetada. Alterações motoras com lateralização, afasia motora associada a hemiparesia e depressão com labilidade afetiva intensa são frequentes. Áreas hiperintensas (na RM T2/FLAIR) ou hipodensas (na TC) aparecem em córtex e substância branca subcortical, são assimétricas e estão dispostas de acordo com o território irrigado pela artéria acometida (Fig. 10.4).

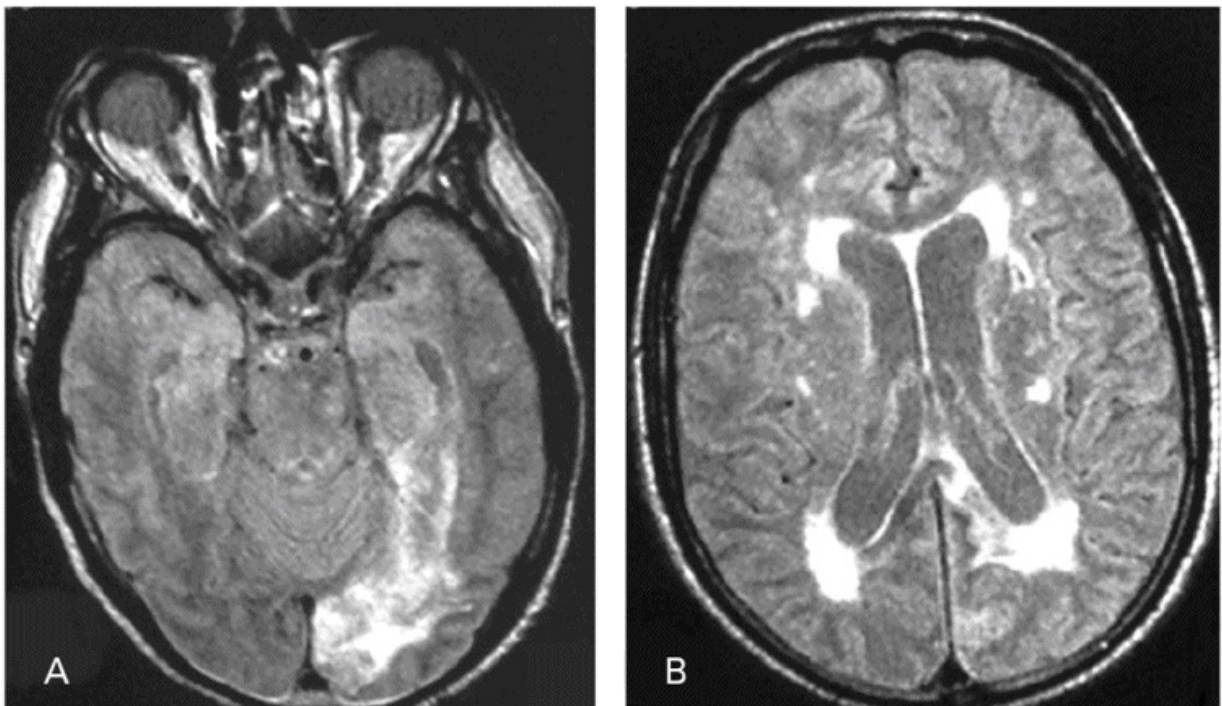


FIGURA 10.4 Homem, 64 anos, afasia, agnosia visual, disfunção executiva, labilidade afetiva e hemiparesia à direita. RM-FLAIR mostra extensa área hiperintensa em região occipitotemporal à esquerda, relacionada a AVC isquêmico (A) e hiperintensidades puntiformes e confluentes em substância branca periventricular e subcortical (Fazekas 2), associadas a microangiopatia (B).

Declínio cognitivo e alterações de comportamento, secundários à doença de pequenos vasos, são mais prevalentes. Seu mecanismo fisiopatológico envolve alterações microangiopáticas que causam lesões axonais, com consequente deafferentação de conexões neurais. As lesões localizam-se mais comumente em substância branca periventricular, e sua gravidade está associada à intensidade e ao controle dos fatores de risco cerebrovasculares. Afetam principalmente circuitos do córtex pré-frontal dorsolateral e do cíngulo anterior, de forma que os sintomas predominantes são disfunção executiva, déficit de memória de trabalho, lentificação da velocidade de processamento, depressão e apatia. Rigidez motora axial e simétrica, alteração de marcha e equilíbrio e urgeincontinência urinária podem aparecer em casos mais graves (chamados doença de Binswanger). O curso é de início insidioso e evolução lenta e progressiva (*Alzheimer-like*). A neuroimagem mostra hiperintensidades puntiformes em substância branca periventricular e/ou subcortical, dispostas bilateral e simetricamente, que podem confluir conforme progridem (Fig. 10.4).

O tratamento deve compreender essencialmente o controle rigoroso dos fatores de risco vasculares. Adicionalmente, estão indicados inibidores de colinesterase para demência de pequenos vasos, tendo em vista a frequente intersecção epidemiológica e fisiopatológica entre microangiopatia e DA. Sintomas depressivo-apáticos secundários à doença de pequenos vasos (depressão vascular) cursam frequentemente com refratariedade e, de acordo com nossa prática clínica, podem apresentar melhores respostas com antidepressivos noradrenérgicos e dopaminérgicos. Fisioterapia para reabilitação motora está bem indicada para doença de grandes e pequenos vasos com sintomas motores.^{13,48}

Degeneração lobar frontotemporal

Compreende um grupo de condições neurodegenerativas e progressivas, que inicialmente resultam na atrofia focal dos lobos frontais e/ou temporais. Vários achados histopatológicos e genéticos foram separadamente associados à degeneração lobar frontotemporal (DLFT), mas a correlação entre genética, histopatologia e clínica ainda é pouco compreendida. Caracteriza-se como uma demência pré-senil e de rápida evolução. Inicia-se na sexta década de vida, e a sobrevida é de 6 a 11 anos após os primeiros sintomas. A DLFT pode ser classificada em duas apresentações clínicas: a variante comportamental e a variante de linguagem.¹⁴

A variante comportamental, também chamada de demência frontotemporal (DFT), é a mais prevalente e cursa primeiramente com alterações do comportamento e atrofia dos lobos frontais (Fig. 10.5). Alterações do julgamento, inadequação social, impulsividade, agressividade, hipersexualidade, labilidade emocional, comportamento estereotipado, compulsões, alterações do comportamento alimentar e comportamento de utilização compõem a sintomatologia típica. Apatia e déficit em funções executivas, atenção e memória de trabalho frequentemente estão associados ou podem dominar o quadro clínico.

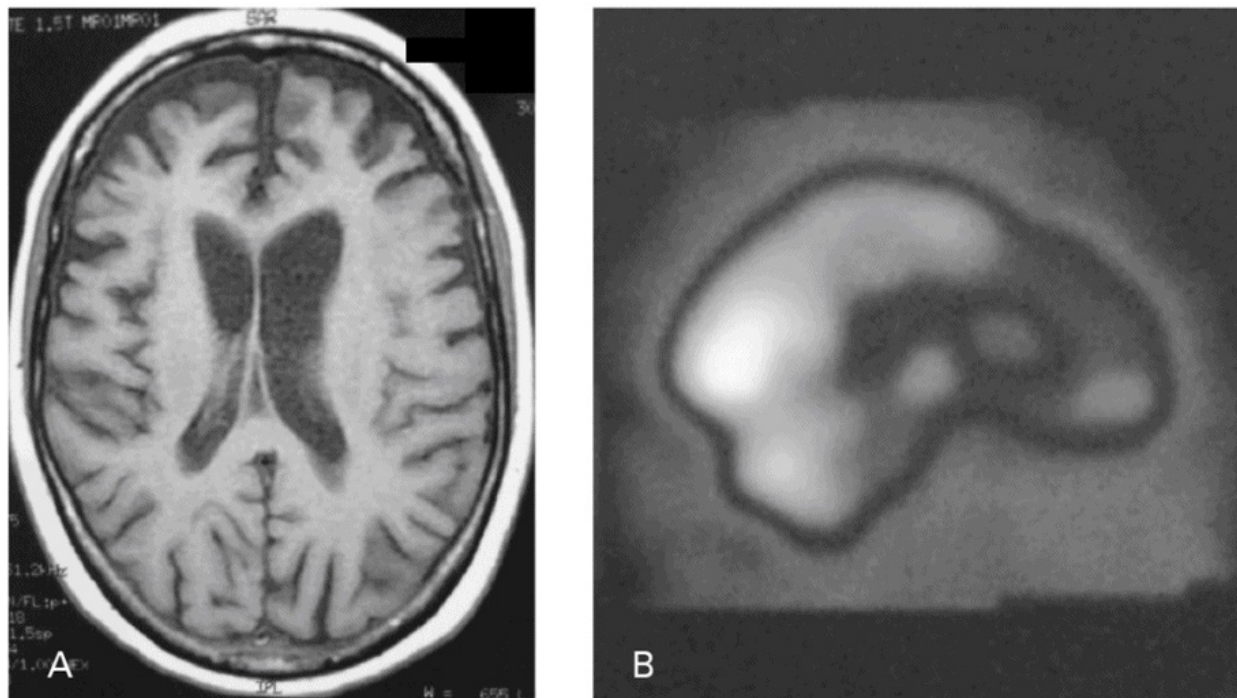


FIGURA 10.5 Mulher, 57 anos, com sintomas cognitivos e neuropsiquiátricos com dois anos de evolução. Diagnóstico de DLFT variante comportamental. Evidenciam-se atrofia em córtex frontal bilateralmente e alargamento dos cornos anteriores dos ventrículos laterais em corte axial da RM-T1 (A). Em (B), a SPECT mostra acentuada hipoperfusão de lobos frontais em corte sagital.

Chamada também de afasia progressiva primária (APP), a variante de linguagem subdivide-se em APP não fluente e APP fluente (ou demência semântica). Em ambas, o quadro clínico inicial é dominado por alterações de linguagem, e, com a evolução, aparecem também disfunção executiva e sintomas comportamentais. Na APP não fluente, ocorrem erros sintáticos e fonêmicos, a fala é hesitante (dispraxia de fala), o discurso apresenta disprosódia e difícil compreensão. Anatomicamente, encontra-se atrofia em região frontoinsular posterior esquerda, incluindo-se a área de Broca e o opérculo frontal. Na APP fluente, a compreensão da linguagem é mais afetada; a fala é fluente, mas com erros semânticos. Está associada a atrofia de polo e corpo temporal à esquerda.

A neuroimagem estrutural pode mostrar achados evidentes de DLFT, conforme apresentado anteriormente. No entanto, quadros iniciais podem cursar apenas com alterações discretas ou até TC e RM normais. Nesses casos, a neuroimagem funcional com FDG-PET ou SPECT é de grande valia, pois pode demonstrar mais precocemente hipometabolismo ou hipoperfusão focal em lobos frontais e/ou temporais, indicativos de DLFT (Fig. 10.5). Análise geral do LCS pode ser necessária diante da suspeita diagnóstica de encefalites. Dosagem de b-amiloide e proteína Tau no LCS ou PiB-PET podem auxiliar no diagnóstico diferencial com variantes não amnésticas da DA. Embora pesquisas recentes tenham associado alguns genes à DLFT, testes genéticos ainda não fazem parte da rotina clínica.

Não há tratamento que modifique a evolução da doença, de modo que as condutas são apenas sintomáticas e de suporte. Antidepressivos serotoninérgicos estão indicados para os sintomas de

agressividade, impulsividade, desinibição, agitação e compulsões. Nesse contexto, a trazodona pode ser uma boa opção, devido a sua ação sedativa. Em casos refratários, recomenda-se associar antipsicóticos atípicos, com baixo risco de sintomas extrapiramidais, como a quetiapina. Psicoestimulantes, como o metilfenidato, podem ajudar em casos de apatia grave. Inibidores da colinesterase e memantina não foram eficazes ou até pioraram o comportamento, de acordo com estudos recentes. Tratamentos não farmacológicos, como orientação e apoio familiar, terapia ocupacional, estimulação cognitiva, fonoterapia, fisioterapia e cuidados de enfermagem, devem estar sempre presentes.⁵¹

α -sinucleinopatias: demência na doença de Parkinson e demência por corpúsculos de Lewy

A doença de Parkinson e a demência por corpúsculos de Lewy são expressões clínicas da mesma fisiopatologia, que envolve acúmulo intraneuronal da proteína α -sinucleína, formando os corpúsculos de Lewy. Por consenso, o diagnóstico de demência por corpúsculos de Lewy é estabelecido quando o declínio cognitivo ocorre antes, concomitante ou em até um ano do aparecimento dos sintomas motores extrapiramidais. Quando os sintomas extrapiramidais ocorrem mais de um ano antes da demência, é feito o diagnóstico de demência secundária à doença de Parkinson. Além da cronologia, há outras diferenças clínicas relevantes entre as duas condições.^{15,16}

Na demência por corpúsculos de Lewy, os domínios cognitivos mais afetados são as funções executivas e a atenção. Há flutuação dos sintomas cognitivos ao longo do dia (*delirium-like*). Alucinações e ilusões visuais vívidas aparecem espontaneamente e logo no início do quadro. Os sintomas extrapiramidais são axiais e simétricos e, de modo geral, caracterizados por rigidez. Alterações de marcha, desequilíbrio, quedas e disautonomia podem ocorrer.

A demência na doença de Parkinson comumente ocorre anos após o início dos sintomas motores. De forma semelhante à demência por corpúsculos de Lewy, os sintomas cognitivos caracterizam-se por déficit em funções executivas e atenção e flutuação ao longo do dia. Ambos estão associados a distúrbio do sono REM, que pode ocorrer anos antes do início do quadro. As alucinações visuais também estão presentes, mas podem ser secundárias à levodopa e a outros medicamentos utilizados no tratamento dos sintomas extrapiramidais. Diferentemente da demência por corpúsculos de Lewy, as alterações motoras tendem a ser apendiculares e assimétricas.

A RM ou a TC não evidenciam achados fortemente indicativos dessas condições, de modo que atrofia cortical generalizada parece ser a alteração mais comumente encontrada. Contudo, alguns casos podem apresentar atrofia mais acentuada em córtex parieto-occipital, que pode estar associada a hipoperfusão ou hipometabolismo, respectivamente, pela SPECT ou FDG-PET, na mesma região. O TRODAT-1 com SPECT apresenta hipocaptação do traçador de dopamina em núcleos da base, em comparação com indivíduos sadios, de forma que auxilia significativamente no diagnóstico diferencial de doença de Parkinson ou de Lewy com outras doenças neurodegenerativas ou cerebrovasculares.^{44,45}

Os sintomas cognitivos e neuropsiquiátricos (inclusive alucinações e delírios) respondem relativamente bem aos inibidores da colinesterase em ambas as condições. Na doença de Parkinson, as alterações motoras têm boa resposta com levodopa e outros agentes dopaminérgicos; já na doença de Lewy, a resposta é insatisfatória. Nos dois casos, antipsicóticos de alta potência de bloqueio dopaminérgico (p. ex., haloperidol, risperidona e olanzapina) devem ser evitados, pois os pacientes apresentam hipersensibilidade aos efeitos colaterais desses fármacos, especialmente sintomas extrapiramidais. Seu uso nessas situações está associado a piora drástica do quadro motor ou rebaixamento do nível de consciência. Diante de SNPs refratários aos inibidores da colinesterase e de difícil manejo não farmacológico, recomenda-se o uso de quetiapina, titulando-se a partir de doses muito baixas (12,5 mg, inicialmente). A fisioterapia é fundamental para reabilitação motora.

Outras síndromes cognitivas

Hidrocefalia de pressão normal (HPN), degeneração corticobasal (DCB), paralisia supranuclear progressiva (PSP) e atrofia de múltiplos sistemas (AMS) são condições menos prevalentes, que cursam com demência e sintomas parkinsonianos. A demência relacionada ao álcool é mais frequente, e seus mecanismos subjacentes podem estar associados a neurotoxicidade do etanol, carência de vitaminas (B1, B12 e ácido fólico), alterações cerebrovasculares, traumatismos cranioencefálicos e insuficiência hepática. Por fim, outras causas de demência são neurolues, HIV, leucoencefalopatia multifocal progressiva (LEMP), doenças priônicas, neurocirurgia e traumas cranioencefálicos.

TRATAMENTOS NO HOSPITAL GERAL

Tratamentos dos sintomas cognitivos

Deve-se aguardar a alta da internação no hospital geral para a decisão de se introduzir ou titular a dose de inibidores da colinesterase e memantina. Tendo em vista que o efeito terapêutico de ambos ocorre apenas em semanas a meses e que efeitos adversos são frequentes durante a titulação, o risco dessas medicações é maior do que os benefícios, quando elas são iniciadas de forma concomitante à descompensação de uma condição médica geral.⁵²

Ademais, os efeitos adversos e as interações farmacológicas dessas medicações podem ser o motivo do pedido de interconsulta. A Tabela 10.1 apresenta os principais efeitos colaterais dos medicamentos para cognição. Diante de efeitos colaterais graves dos inibidores da colinesterase, como bradicardia sintomática, piora da função pulmonar, vômitos e perda de peso acentuada por inapetência, o fármaco deve ser suspenso imediatamente. A memantina deve ser retirada se estiver claramente associada a confusão mental e sintomas psicóticos.⁵³

Tabela 10.1

Inibidores da colinesterase e memantina ^{52,53}

	Dose inicial	Faixa terapêutica	Mecanismo de ação	Metabolização	Meia-vida	Principais efeitos adversos
Donepezila	5 mg	5-10 mg	Inibição seletiva da acetilcolinesterase	CYP2D6 CYP3A4	70h	Náusea (3-19%), vômitos (3-8%), diarreia (5-15%), insônia (2-14%), cefaleia (3-10%), cãimbras (3-8%), cansaço (3-8%), anorexia (2-8%), perda de peso,* síncope (2%), bradicardia*
Rivastigmina (oral)	1,5 mg	6-12 mg	Inibição da acetil e da butirilcolinesterase	Extra-hepática	1,5h	Náusea (47%), vômitos (31%), diarreia (19%), anorexia (17%), perda de peso (3-8%), bradicardia (1-10%)
Rivastigmina (adesivo)	5 mg	10-15 mg	Inibição da acetil e da butirilcolinesterase	Extra-hepática	3h	Náusea (21%), vômitos (6-19%), diarreia (6-10%), anorexia (3-9%), perda de peso (3-8%), bradicardia (1-10%)
Galantamina (liberação prolongada)	8 mg	16-24 mg	Inibição da acetilcolinesterase e ação alostérica em receptores nicotínicos	CYP2D6 CYP3A4	7h	Náusea (20-15%), vômitos (11-15%), diarreia (11-15%), anorexia (1-10%), perda de peso (1-10%), bradicardia (1-10%), síncope (1-10%), cansaço (1-10%), cãimbras (1-10%), cefaleia (1-10%), insônia/sonolência (1-10%)
Memantina	5 mg	10-20 mg	Antagonismo do receptor NMDA**	Extra-hepática	60-80h	Tontura (7%), confusão mental (6%), cefaleia (6%), constipação (6%), sonolência (3%), cansaço (2%)

* Frequência não definida

** N-metil-D-aspartato

Tratamentos dos sintomas neuropsiquiátricos

A primeira linha de tratamento dos SNP são abordagens não farmacológicas. Após a descrição minuciosa dos sintomas e a identificação ampla dos fatores associados, deve-se criar estratégias de manejo dos possíveis contribuintes para o aparecimento das alterações de comportamento. A participação de familiares e cuidadores, que conhecem a personalidade e os hábitos do paciente, bem como de todos os profissionais da saúde envolvidos no cuidado durante a internação, é fundamental na construção e na implementação das condutas. Os resultados devem ser

rotineiramente avaliados por todos, e novas estratégias podem ser tentadas diante de respostas insatisfatórias. O Quadro 10.2 apresenta sugestões de manejo para os SNP.²⁷

O uso de psicofármacos tem mostrado baixa eficácia para sintomas comportamentais e alto risco de efeitos adversos em idosos (ver Caps. 23 a 25). Antipsicóticos têm sido independentemente associados a eventos cerebrovasculares e morte, além de implicarem risco de sintomas extrapiramidais (rigidez e acatisia, principalmente), sedação excessiva, piora da mobilidade, quedas, disfagia, broncoaspiração e constipação intestinal.⁵⁴

Em uma metanálise com 46.008 idosos com demência e SNPs tratados farmacologicamente, Maust e colaboradores mostraram que, comparado a controles sem medicação, o risco de morte associado ao haloperidol foi de 3,8%; à risperidona, de 3,7%; à olanzapina, de 2,5%; e à quetiapina, de 2,0%.⁵⁵ Antipsicóticos de primeira geração e de baixa potência (como clorpromazina e levomepromazina), via de regra, não são recomendados, devido ao elevado risco de sedação, quedas, hipotensão arterial e piora dos sintomas cognitivos.

Antidepressivos são mais seguros. Mas inibidores seletivos da recaptação da serotonina podem causar hiponatremia, alargamento do intervalo QTc e dispepsia. Antidepressivos dopaminérgicos e noradrenérgicos estão associados a hipertensão arterial, insônia, irritabilidade e agitação psicomotora. Tricíclicos não são aconselhados, devido aos efeitos anticolinérgicos centrais e periféricos.^{54,56}

Benzodiazepínicos podem levar a piora da cognição, sedação excessiva, hipotensão e quedas. Psicoestimulantes frequentemente levam a hipertensão, taquicardia, inapetência e insônia. Anticonvulsivantes e carbonato de lítio não se mostraram eficazes e não são usados para alterações de comportamento secundárias a doenças neurodegenerativas e cerebrovasculares.⁵⁴

O tratamento psicofarmacológico é recomendado apenas se houver falha nas abordagens não medicamentosas ou se o comportamento implica alto risco para o paciente ou outros. Assim, para ansiedade, labilidade, agitação, agressividade, insônia e perambulação noturna, sugerem-se antidepressivos, como trazodona, sertralina, citalopram e escitalopram, que também são recomendados para sintomas depressivos graves e risco de suicídio.

Antipsicóticos podem ser usados para delírios e alucinações, além de agressividade e agitação psicomotora graves, devido a sua ação mais rápida e incisiva. Sugere-se titular lenta e gradualmente, a partir de baixas doses, e suspender o uso após estabilização da melhora. Tendo em vista o menor risco, a quetiapina pode ser a primeira escolha, mas alguns pacientes não respondem satisfatoriamente devido ao baixo poder de bloqueio dopaminérgico. Nesses casos, doses baixas de risperidona podem ajudar.

Benzodiazepínicos podem ser utilizados em situações especiais, como ansiedade grave ou agitação intensa, que exigem efeito ansiolítico e/ou sedativo imediato. Sugere-se o lorazepam devido ao perfil de metabolização mais favorável. O uso criterioso de psicoestimulantes pode ser uma opção adicional para apatia grave, quando outras estratégias, principalmente as não farmacológicas, não surtirem o efeito desejado.^{22,23,54,57}

REFERÊNCIAS

1. United Nations, Department of Economic and Social Affairs, Population Division. World population ageing. New York: United Nations; 2015.
2. Fratiglioni L, Qiu C. Epidemiology of dementia. In: Denning T, Thomas A, editors. Oxford textbook of old age psychiatry. Oxford: Oxford University; 2013. p. 389-413.
3. Stewart R. Mild cognitive impairment: the continuing challenge of its “real-world” detection and diagnosis. Arch Med Res. 2012;43(8):609-14.
4. Tranel D. Neuroanatomia funcional. Correlatos neuropsicológicos de lesões corticais e subcorticais. In: Yudofsky SC, Hales RE. Neuropsiquiatria e neurociências na prática clínica. 4. ed. Porto Alegre: Artmed; 2006. p. 77-112.
5. Albert MS, Dekosky ST, Dickson D, Dubois B, Feldman HH, Fox NC, et al. The diagnosis of mild cognitive impairment due to Alzheimer’s disease: recommendations from the National Institute on Aging-Alzheimer’s Association workgroups on diagnostic guidelines for Alzheimer’s disease. Alzheimer’s Dement. 2011;7(3):270-9.
6. Lezak MD, Howieson DB, Bigler ED, Tranel D. Neuropsychological assessment. 5th ed. New York: Oxford University; 2012.
7. Stahl SM. Stahl’s essential psychopharmacology: neuroscientific basis and practical applications. 3rd ed. New York: Cambridge University; 2008.
8. Strauss E, Sherman EMS, Spreen O. A compendium of neuropsychological test. Administration, norms, and commentary. 3rd ed. New York: Oxford University; 2006. p. 75-85.
9. Folstein MF, Folstein SE, McHugh PR. A practical method for grading the cognitive state of patients for clinicians. J Psychiat Res. 1975;12: 189-98.
10. Bertolucci PH, Brucki SM, Campacci SR, Juliano Y. The mini-mental state examination in a general population: impact of educational status. Arq Neuropsiquiatr. 1994;52(1):1-7.
11. Brucki SMD, Nitrini R, Caramelli P, Bertolucci PHF, Okamoto IH. Sugestões para o uso do mini-exame do estado mental no Brasil. Arq Neuropsiquiatr. 2003;61(3):777-81.
12. Nitrini R, Caramelli P, Bottino CM, Damasceno BP, Brucki SMD, Anghinah R. Diagnóstico de doença de Alzheimer no Brasil. Avaliação Cognitiva e Funcional. Recomendações do Departamento Científico de Neurologia Cognitiva e do Envelhecimento da Academia Brasileira de Neurologia. Arq Neuropsiquiatr. 2005;63(3):720-27.
13. Brien JTO, Thomas A. Non-alzheimer’s dementia 3. Vascular dementia. Lancet. 2015;386:1698-706.
14. Karageorgiou E, Miller BL. Frontotemporal lobar degeneration: a clinical approach. Semin Neurol. 2014;34(2):189-201.
15. McKeith IG, Dickson DW, Lowe J, Emre M, O’Brien JT, Feldman H, et al. Diagnosis and management of dementia with Lewy bodies Third report of the DLB consortium. Neurology. 2005;65(12):1863-72.

16. Pagonabarraga J, Kulisevsky J. Neurobiology of disease. Cognitive impairment and dementia in Parkinson's disease. *Neurobiol Dis.* 2012;46(3):590-6.
17. Shulman KI, Shedletsky R, Silver I. The challenge of time: clock drawing and cognitive function in the elderly. *Int J Geriatr Psychiatry.* 1986;1(2):135-40.
18. Kato Y, Narumoto J, Matsuoka T, Okamura A, Koumi H, Kishikawa Y, et al. Diagnostic performance of a combination of mini-mental state examination and clock drawing test in detecting alzheimer's disease. *Neuropsychiatr Dis Treat.* 2013;9:581-6.
19. Rossetti HC, Lacritz LH, Cullum CM, Weiner MF. Normative data for the Montreal Cognitive Assessment (MoCA) in a population-based sample. *Neurology.* 2011;77(13):1272-5.
20. Memória CM, Yassuda MS, Nakano EY, Forlenza OV. Brief screening for mild cognitive impairment: validation of the Brazilian version of the Montreal cognitive assessment. *Int J Geriatr Psychiatry.* 2013;28(1):34-40.
21. Maria V, Passos DA, Giatti L, Bensenor I, Tiemeier H, Ikram MA, et al. Education plays a greater role than age in cognitive test performance among participants of the Brazilian Longitudinal Study of Adult Health. *BMC Neurol.* 2015;15:191-200.
22. Lyketsos CG, Carrillo MC, Ryan JM, Khachaturian AS, Trzepacz P, Amatniek J, et al. Neuropsychiatric symptoms in Alzheimer's disease. *Alzheimer's Dement.* 2011;7(5):532-9.
23. Geda YE, Schneider LS, Gitlin LN, Miller DS, Smith GS, Bell J, et al. Neuropsychiatric symptoms in Alzheimer's disease: past progress and anticipation of the future. *Alzheimers Dement.* 2013;9(5):602-8.
24. Medeiros K, Robert P, Gauthier S, Stella F, Politis A, Leoutsakos J, et al. The Neuropsychiatric Inventory-Clinician rating scale (NPI-C): reliability and validity of a revised assessment of neuropsychiatric symptoms in dementia. *Int Psychogeriatr.* 2010;22(6):984-94.
25. Cummings JL. The Neuropsychiatric Inventory: assessing psychopathology in dementia patients. *Neurology.* 1997;48(5 Suppl 6):S10-6..
26. Stella F, Forlenza OV, Laks J, Andrade LP De, Avendaño MAL, Villela E, et al. The Brazilian version of the Neuropsychiatric Inventory-Clinician rating scale (NPI-C): reliability and validity in dementia. *Int Psychogeriatr.* 2013;25(9):1503-11.
27. Kales HC, Gitlin LN, Lyketsos CG; Detroit Expert Panel on Assessment and Management of Neuropsychiatric Symptoms of Dementia. Management of neuropsychiatric symptoms of dementia in clinical settings: recommendations from a multidisciplinary expert panel. *J Am Geriatr Soc.* 2014;62(4):762-9.
28. Jessen F, Amariglio RE, Boxtel M Van, Breteler M, Dubois B, Dufouil C, et al. A conceptual framework for research on subjective cognitive decline in preclinical Alzheimer's disease. *Alzheimers Dement.* 2014;10(6):844-52.
29. Reisberg B, Jamil IA, Khan S, Monteiro I, Torossian C, Ferris S, et al. Staging dementia. In: Abou-Saleh MT, Katona C, Kumar A, editors. *Principles and practice of geriatric psychiatry.* 3rd ed. Oxford: John Wiley & Sons; 2011. p. 162-9.

30. Cozzensa M. Disability relating to basic and instrumental activities of daily living among elderly subjects. *Rev Saúde Pública*. 2009;43(5):796-805.
31. Pfeffer RI, Kurosaki TT, Harrah CH Jr, Chance JM, Filos S. Measurement of functional activities in older adults in the community. *J Gerontol*. 1982;37(3):323-9.
32. Sclan SG, Reisberg B. Functional Assessment Staging (FAST) in Alzheimer's disease: Reliability, Validity, and Ordinality. *Int Psychogeriatr*. 1992;4 Suppl 1:55-69.
33. Porto SC. *Semiologia médica*. 7. ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan; 2013.
34. Martins Jr CR, França Jr MC, Martinez ARM, Faber I, Nucci A. *Semiologia neurológica*. Rio de Janeiro: Revinter; 2017.
35. American Psychiatric Association. *Manual diagnóstico e estatístico de transtornos mentais: DSM-5*. 5. ed. Porto Alegre: Artmed, 2014.
36. Dubois B, Hampel H, Feldman HH, Scheltens P, Aisen P, Andrieu S, et al. Preclinical Alzheimer's disease: Definition, natural history, and diagnostic criteria. *Alzheimers Dement*. 2016;12(3):292-323.
37. Forlenza O V, Diniz BS, Stella F, Teixeira AL, Gattaz WF. Mild cognitive impairment (part 1): clinical characteristics and predictors of dementia. *Rev Bras Psiquiatr*. 2013;35(2):178-85.
38. Mckhann GM, Knopman DS, Chertkow H, Hyman BT, Jack CR, Kawas CH, et al. The diagnosis of dementia due to Alzheimer's disease: recommendations from the National Institute on Aging-Alzheimer's Association workgroups on diagnostic guidelines for Alzheimer's disease. *Alzheimers Dement*. 2011;7(3):263-9.
39. Bertelson JA. Neuroimaging of dementia. *Neurol Clin NA*. 2014;32(1):59-93.
40. Wattjes MP. Structural MRI. *Int Psychogeriatr*. 2011;23 Suppl 2:S13-24.
41. Valk J, Barkhof F, Scheltens P. *Ressonância magnética na demência*. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan; 2004.
42. Wahlund LO, Barkhof F, Fazekas F, Bronge L, Augustin M, Sjögren M, et al. A new rating scale for age-related white matter changes. *Stroke*. 2001;32(6):1318-22.
43. Duara R, Loewenstein DA, Shen Q, Barker W, Varon D, Greig MT, et al. The utility of age-specific cut-offs for visual rating of medial temporal atrophy in classifying Alzheimer's disease, MCI and cognitively normal elderly subjects. *Front Aging Neurosci*. 2013;5:47.
44. Herholz K. Perfusion SPECT and FDG-PET. *Int Psychogeriatr*. 2011;23 Suppl 2:S25-31.
45. Walker Z, Rodda J. Dopaminergic imaging: clinical utility now and in the future. *Int Psychogeriatr*. 2011;23 Suppl 2:S32-40.
46. Farrer LA, Cupples LA, Haines JL, Hyman B, Kukull WA, Mayeux R, et al. Effects of age, sex, and ethnicity on the association between apolipoprotein e genotype and Alzheimer disease. *JAMA*. 1997;278(16):1349-56.
47. Wu L, Rosa-neto P, Hsiung GR, Sadovnick AD, Masellis M, Black SE, et al. Early-Onset Familial Alzheimer's Disease (EOFAD). *Can J Neurol Sci*. 2012;39(4):436-45.
48. Farooq MU, Gorelick PB. Vascular cognitive impairment. *Curr Atheroscler Rep*. 2013;15(6):330.

49. Gofton TE. Delirium: a review. *Can J Neurol Sci.* 2011;38(5):673-80.
50. Ballard C, Gauthier S, Corbett A, Brayne C, Aarsland D, Jones E. Alzheimer's disease. *Lancet.* 2011;377(9770):1019-31.
51. Nardell M, Tampi RR. Pharmacological treatments for frontotemporal dementias: a systematic review of randomized controlled trials. *Am J Alzheimers Dis Other Dement.* 2014;29(2):123-32.
52. Gauthier S, Molinuevo JL. Benefits of combined cholinesterase inhibitor and memantine treatment in moderate-severe Alzheimer's disease. *Alzheimers Dement.* 2013;9(3):326-31.
53. Reference.medscape.com [Internet]. New York: Medscape; c1994-2016 [capturado em 19 dez. 2016]. Disponível em: <http://reference.medscape.com/>.
54. Mcclam TD, Marano CM, Rosenberg PB, Lyketsos CG. Interventions for neuropsychiatric symptoms in neurocognitive impairment due to alzheimer's disease: a review of the literature. *Harv Rev Psychiatry.* 2015;23(5):377-93.
55. Maust DT, Kim HM, Seyfried LS, Chiang C, Kavanagh J, Schneider LS, et al. Antipsychotics, other psychotropics, and the risk of death in patients with dementia. Number needed to harm. *JAMA Psychiatry.* 2015;72(5):438-45.
56. Ellison JM, Kyomen HH. Depression in later life: an overview with treatment. *Psychiatr Clin N Am.* 2012;35(1):203-29.
57. Berman K, Brodaty H, Withall A, Seeher K. Pharmacologic treatment of apathy in dementia. *Am J Geriatr Psychiatry.* 2012;20(2):104-22.

MINIEXAME DO ESTADO MENTAL⁹

Paciente: _____

Data da avaliação: ____/____/____ Avaliador: _____

Orientação

- Dia da semana (1 ponto) ()
- Dia do mês (1 ponto) ()
- Mês (1 ponto) ()
- Ano (1 ponto) ()
- Hora aproximada (1 ponto) ()
- Local específico (andar ou setor) (1 ponto) ()
- Instituição (residência, hospital, clínica) (1 ponto) ()
- Bairro ou rua próxima (1 ponto) ()
- Cidade (1 ponto) ()
- Estado (1 ponto) ()

Memória imediata

- Fale 3 palavras não relacionadas. Posteriormente pergunte ao paciente pelas 3 palavras. Dê 1 ponto para cada resposta correta ()
- Depois repita as palavras e certifique-se de que o paciente as aprendeu, pois mais adiante você irá perguntá-las novamente.

Atenção e cálculo

- (100 – 7) sucessivos, 5 vezes sucessivamente (1 ponto para cada cálculo correto) ()
- (alternativamente, soletrar MUNDO de trás para a frente)

Evocação

- Pergunte pelas 3 palavras ditas anteriormente (1 ponto por palavra) ()

Linguagem

- Nomear um relógio e uma caneta (2 pontos) ()
- Repetir “Nem aqui, nem ali, nem lá” (1 ponto) ()
- Comando: “pegue este papel com a mão direita, dobre ao meio e coloque no chão” (3 pontos) ()
- Ler e obedecer: “feche os olhos” (1 ponto) ()
- Escrever uma frase (1 ponto) ()
- Copiar um desenho (1 ponto) ()

Escore: (____/30)



Nome: _____ Data de nascimento: ____/____/____
Escolaridade: _____ Data de avaliação: ____/____/____
Sexo: _____ Idade: _____

VISUOESPACIAL / EXECUTIVA		Copiar o cubo		Desenhar um RELÓGIO (onze horas e dez minutos) (3 pontos)		Pontos			
[]		[]		[]	[]	[]			
				Contorno	Números	Ponteiros			
						—/5			
NOMEAÇÃO									
[]		[]		[]		—/3			
MEMÓRIA		Leia a lista de palavras, O sujeito de repeti-la, faça duas tentativas. Evocar após 5 minutos.		Rosto	Veludo	Igreja	Margarida	Vermelho	Sem Pontuação
		1ª tentativa							
		2ª tentativa							
ATENÇÃO		Leia a sequência de números (1 número por segundo).		O sujeito deve repetir a sequência em ordem direta [] 2 1 8 5 4		O sujeito deve repetir a sequência em ordem indireta [] 7 4 2			
									—/2
Leia a série de letras. O sujeito deve bater com a mão (na mesa) cada vez que ouvir a letra "A". Não se atribuem pontos se ≥ 2 erros.		[] F B A C M N A A J K L B A F A K D E A A A J A M O F A A B							—/1
Subtração de 7 começando pelo 100 [] 93 [] 86 [] 79 [] 72 [] 65		4 ou 5 subtrações corretas: 3 pontos; 2 ou 3 corretas 2 pontos; 1 correta 1 ponto; 0 correta 0 ponto							—/3
LINGUAGEM		Repetir: Eu somente sei que é João quem será ajudado hoje. []		O gato sempre se esconde embaixo do Sofá quando o cachorro está na sala. []					—/2
Fluência verbal: dizer o maior número possível de palavras que comecem pela letra F (1 minuto). [] _____ (N ≥ 11 palavras)									—/1
ABSTRAÇÃO		Semelhança p. ex. entre banana e laranja = fruta [] trem - bicicleta [] relógio - régua							—/2
EVOCAÇÃO TARDIA		Deve recordar as palavras SEM PISTAS		Rosto	Veludo	Igreja	Margarida	Vermelho	Pontuação apenas para evocação SEM PISTAS
				[]	[]	[]	[]	[]	
OPCIONAL		Pista de categoria							
		Pista de múltipla escolha							
ORIENTAÇÃO		[] Dia do mês [] Mês [] Ano [] Dia da semana [] Lugar [] Cidade							—/6
© Z. Nasreddine MD www.mocatest.org Versão experimental Brasileira: Ana Luisa Rosas Sarmento Paula Henrique, Fernão Botelho, José Roberto Moimim		TOTAL Adicionar 1 pt se ≤ 12 anos de escolaridade							—/30

QUESTIONÁRIO DE ATIVIDADES FUNCIONAIS³¹
(Pfeffer et al., 1982)

Nome: _____ Idade: _____

Data da avaliação: ____/____/____ Acompanhante: _____

- 1) Ele(a) manuseia seu próprio dinheiro?
0 = Normal, ou nunca o fez, mas poderia fazê-lo agora
1 = Faz com dificuldade, ou nunca o fez e agora teria dificuldade
2 = Necessita de ajuda
3 = Não é capaz
- 2) Ele(a) é capaz de comprar roupas, comida, coisas para casa sozinho(a)?
0 = Normal, ou nunca o fez, mas poderia fazê-lo agora
1 = Faz com dificuldade, ou nunca o fez e agora teria dificuldade
2 = Necessita de ajuda
3 = Não é capaz
- 3) Ele(a) é capaz de esquentar água para o café e apagar o fogo?
0 = Normal, ou nunca o fez, mas poderia fazê-lo agora
1 = Faz com dificuldade, ou nunca o fez e agora teria dificuldade
2 = Necessita de ajuda
3 = Não é capaz
- 4) Ele(a) é capaz de preparar uma comida?
0 = Normal, ou nunca o fez, mas poderia fazê-lo agora
1 = Faz com dificuldade, ou nunca o fez e agora teria dificuldade
2 = Necessita de ajuda
3 = Não é capaz
- 5) Ele(a) é capaz de manter-se em dia com as atualidades, com os acontecimentos da comunidade ou da vizinhança?
0 = Normal, ou nunca o fez, mas poderia fazê-lo agora
1 = Faz com dificuldade, ou nunca o fez e agora teria dificuldade
2 = Necessita de ajuda
3 = Não é capaz
- 6) Ele(a) é capaz de prestar atenção, entender e discutir um programa de rádio ou televisão, um jornal ou uma revista?
0 = Normal, ou nunca o fez, mas poderia fazê-lo agora
1 = Faz com dificuldade, ou nunca o fez e agora teria dificuldade
2 = Necessita de ajuda
3 = Não é capaz
- 7) Ele(a) é capaz de lembrar-se de compromissos, acontecimentos familiares, feriados?
0 = Normal, ou nunca o fez, mas poderia fazê-lo agora
1 = Faz com dificuldade, ou nunca o fez e agora teria dificuldade
2 = Necessita de ajuda
3 = Não é capaz
- 8) Ele(a) é capaz de manusear seus próprios remédios?
0 = Normal, ou nunca o fez, mas poderia fazê-lo agora
1 = Faz com dificuldade, ou nunca o fez e agora teria dificuldade
2 = Necessita de ajuda
3 = Não é capaz
- 9) Ele(a) é capaz de passear pela vizinhança e encontrar o caminho de volta para casa?
0 = Normal, ou nunca o fez, mas poderia fazê-lo agora
1 = Faz com dificuldade, ou nunca o fez e agora teria dificuldade
2 = Necessita de ajuda
3 = Não é capaz
- 10) Ele(a) pode ser deixado(a) em casa sozinho(a) de forma segura?
0 = Normal, ou nunca o fez, mas poderia fazê-lo agora
1 = Faz com dificuldade, ou nunca o fez e agora teria dificuldade
2 = Necessita de ajuda
3 = Não é capaz

Escore: > 5 indicam prejuízo funcional
Pontuação total: ____/30

[NT] Instruções de aplicação passo a passo e dados normativos podem ser acessados em www.mocatest.org.



Interconsulta de crianças

Antonio Carvalho de Ávila Jacintho
Eloisa Helena Rubello Valler Celeri

A interconsulta psiquiátrica na infância surge como decorrência do fato de que crianças hospitalizadas em enfermarias de pediatria têm maior prevalência de transtornos mentais quando comparadas com crianças da população em geral.¹⁻⁴ Em casos de patologias crônicas, as taxas de prevalência podem ser de 2 a 4 vezes mais altas.⁵ Além disso, familiares dessas crianças são mais vulneráveis a transtornos psiquiátricos, como o transtorno de estresse pós-traumático (TEPT).⁶ Certas situações vivenciadas na enfermaria também podem gerar angústia e outras reações emocionais nos membros da equipe assistencial.⁷ Este capítulo ocupa-se das nuances que envolvem a interconsulta em psiquiatria infantil, destacando questões relativas à violência contra a criança e à psicodinâmica da família e da equipe assistencial.

Ao longo do século XX, graças aos avanços na antibioticoterapia, na imunoprofilaxia e nos cuidados nutricionais com o bebê e a criança pequena, observou-se diminuição importante da morbidade e da mortalidade infantis.

Além disso, a valorização dos aspectos inconscientes, proposta por Freud,⁸ e a ideia da existência de um mundo interno operante na criança, desde o nascimento, segundo Klein,⁹ somadas aos trabalhos de Spitz,¹⁰ Bowlby,¹¹ Robertson e Bowlby¹² e Freud,¹³ conduziram a um aumento do interesse pela promoção do desenvolvimento físico e emocional da criança.

A conscientização sobre os riscos trazidos pelas rupturas dos vínculos afetivos na infância levou os hospitais a, progressivamente, encorajar as mães a permanecer com seus filhos durante as internações e a participar de seus cuidados. Pediatras passaram a se interessar de modo mais intenso pela saúde mental das crianças hospitalizadas. Tal interesse incrementou a aproximação entre pediatras e psiquiatras infantis, nascendo, assim, a interconsulta psiquiátrica infantil.¹⁴⁻¹⁵

Alguns autores propõem a existência de diferentes modelos de interconsulta psiquiátrica infantil, como antecipatório (antecedendo uma cirurgia, um transplante ou uma amputação), para a detecção precoce de problemas psíquicos, treinamento e educação da equipe pediátrica (ensino), atendimento de intercorrências psiquiátricas e atendimento colaborativo continuado (p. ex., doenças crônicas, transtornos alimentares, dor, etc.).¹⁶⁻¹⁸

Inúmeras dificuldades poderão estar associadas ao processo de interconsulta psiquiátrica em pediatria, como dificuldade do psiquiatra infantil em compreender a prática do pediatra (e vice-versa), diferentes percepções do paciente (saúde *versus* doença), estigma ligado à doença mental e à prática psiquiátrica, número reduzido de psiquiatras infantis no mundo, acompanhamento após a alta, etc.¹⁹⁻²¹

O psiquiatra poderá ser consultado tanto em situações nas quais a criança apresenta um quadro psiquiátrico instalado e bem definido quanto em casos em que o processo de adoecer provoca repercussões emocionais. Entre as situações mais frequentes, podemos citar crianças com aids, crianças vítimas de queimaduras, câncer, malformação congênita, que sofreram violência, doenças crônicas, múltiplas internações, tentativas de suicídio e adversidades psicossociais.

A doença física na criança deve, necessariamente, ser pensada a partir de uma perspectiva que contemple as questões ligadas ao desenvolvimento. Por se tratar de um ser em formação, a criança passa por diferentes etapas em seu processo de desenvolvimento físico e mental. O desenvolvimento cognitivo e emocional deve sempre ser considerado pelo psiquiatra quando chamado para avaliar uma criança enferma. O conhecimento que a criança tem de seu corpo e dos processos de adoecer vai variar de acordo com a fase do desenvolvimento em que ela se encontra.

Para avaliar o grau de compreensão da criança em relação à doença, é necessário solicitar que ela fale, com suas próprias palavras, sobre como percebe o que está lhe ocorrendo. Isso ajudará o médico e a equipe na condução do tratamento, além de promover maior adesão da criança ao projeto terapêutico proposto.

A CRIANÇA HOSPITALIZADA

A enfermidade provoca uma série de respostas emocionais, sobretudo a regressão e o retraimento. As dores, a fadiga, a febre e outros sintomas físicos provocam mudanças na vivência que a criança tem de seu esquema corporal e de seu “sentimento de si”, podendo, a essas vivências, associar-se um estado de angústia mais ou menos consciente.

Dentro do hospital, a criança vivenciará situações novas e, às vezes, incompreensíveis. Ela pode não contar com o apoio de um adulto confiável a quem perguntar suas dúvidas ou, quando faz perguntas, pode não obter respostas ou recebê-las de maneira pouco clara ou evasiva, o que só faz aumentar sua ansiedade.

Quase todas as crianças reagem à experiência da hospitalização com ansiedade, depressão, apego exagerado aos pais, diminuição da autoestima, recusa ou mau rendimento escolar e falta de adesão ao tratamento, que são os problemas mais frequentes. A intensidade dessas dificuldades é variável e depende de vários fatores, a saber: idade da criança, nível do desenvolvimento psicológico, personalidade e capacidade de adaptação, tipo de doença e repercussão sociocultural, existência de internações anteriores, tempo de hospitalização, grau de informação que a criança tem sobre sua doença, equilíbrio familiar, frequência das visitas familiares, cuidados afetivos, grau de prostração, dor e tipo e efeito do tratamento.²²⁻²⁵

Na criança, a doença reforça os vínculos de dependência e necessidade de proteção entre ela e os adultos que dela cuidam, primeiramente os pais, depois os médicos e seus colaboradores.²⁶

O processo pelo qual o diagnóstico é estabelecido desempenha um papel importante na capacidade de a criança e seus pais se adaptarem à doença. Mesmo quando a investigação diagnóstica é demorada, a família deve ser mantida constantemente informada, o que contribui para diminuir desentendimentos e confusões acerca do real estado da criança.

A busca de sentido para o adoecimento é parte essencial das preocupações familiares. A tentativa de atribuição de sentido é inerente ao ser humano, assim como o são a reflexão sobre a morte e o significado da vida.²⁷⁻²⁹ Essa necessidade de sentido pode fazer os pais se considerarem responsáveis pelo aparecimento da doença, seja por fatores hereditários, seja por ações diretas ou indiretas em relação ao filho. A angústia que o sentimento de culpa provoca pode ser projetada, principalmente, sobre a figura do médico ou da equipe de saúde.

A compreensão consciente (fatores cognitivos) é um componente importante da resposta da criança à doença e à hospitalização. Daí a necessidade de a criança receber, do médico e de seus familiares, uma explicação consistente e adequada a sua capacidade de compreensão. O vocabulário deve ser simples e direto, mas a compreensão intelectual não é tudo.³⁰ Fantasias também podem alterar a percepção e a compreensão que a criança tem sobre sua doença, os procedimentos médicos e o tratamento. A doença pode parecer, para a criança, a confirmação de que seus erros, mesmo que feitos secretamente, são passíveis de punição.

A CRIANÇA HOSPITALIZADA E SUA FAMÍLIA

Os relacionamentos do bebê e da criança com seus cuidadores primários (em geral, mãe e pai) têm papel essencial sobre os múltiplos domínios do desenvolvimento, o que foi constatado desde a primeira metade do século XX. Esses domínios incluem a capacidade de vinculação e o desenvolvimento socioemocional, assim como o comportamento, a coordenação motora e o desenvolvimento da moralidade, da cognição e da aprendizagem, da curiosidade e da linguagem, bem como o próprio desenvolvimento físico.

Esse relacionamento inicial depende da condição parental de se vincular ao bebê. Esse processo se inicia durante a gestação e se prolonga por toda a vida, sendo responsável pela capacidade desses pais de se manterem conectados e comprometidos com o cuidado dos filhos durante todo o seu desenvolvimento.

Pais com transtornos afetivos (incluindo depressão pós-parto), transtornos de ansiedade, psicóticos ou da personalidade, bem como aqueles que estão passando por situações de grave estresse, como a doença grave de um filho, podem apresentar um profundo comprometimento da capacidade de se sintonizar e de se vincular com a criança.

Crianças com condições médicas que interferem na alimentação ou dificultam a possibilidade de contato físico e experiências de acolhimento pelos pais, em UTI neonatal, bem como aquelas com patologias que afetam profundamente a aparência física, podem representar desafios significativos ao processo de vinculação, requerendo dos pais maior maturidade e tolerância à frustração. A equipe médica pode desempenhar um papel crucial em auxiliar os pais, favorecendo e promovendo condições para o desenvolvimento ou a manutenção de suas capacidades de vinculação.

Inúmeros sentimentos podem aflorar também entre os membros da equipe assistencial. Muitos pedidos de interconsulta trazem, portanto, questões mais pertinentes à família e à equipe cuidadora do que à própria criança.

Outras vezes, o interconsultor se vê diante de situações socioculturais muito difíceis, tais como pobreza extrema, ambiente familiar violento, abuso sexual intrafamiliar, custódia e guarda da criança, entre outras. Algumas dessas situações são muito delicadas, envolvendo, além dos aspectos psiquiátricos, questões éticas e legais.

A CRIANÇA COM CÂNCER

Na infância, a leucemia é o tipo de câncer mais frequente. Com o avanço da quimioterapia e da radioterapia, o curso dessa patologia foi muito alterado. Apesar dos progressos, muitas crianças ainda morrem com essa doença.

O tratamento é difícil para a criança e sua família. As internações são comuns, os procedimentos são dolorosos e invasivos, provocando isolamento, perda de peso e de cabelo, náuseas, vômitos e a possibilidade concreta da morte. Muitos pais e, às vezes, a própria equipe assistencial tentam negar a morte, o que sobrecarrega a criança, que se vê obrigada a demonstrar falso bem-estar e falsa disposição para não decepcionar seus cuidadores.^{31,32}

Uma menina de 9 anos, com diagnóstico de leucemia mieloide aguda, que não respondeu à quimioterapia, disse ao seu interconsultor: “Antes eu andava, depois conseguia ficar sentada, agora não. Antes tomava remédio três vezes por dia, agora é toda hora. Não tenho vontade nem de brincar, mas todo mundo entra aqui e diz que eu estou melhor, que vou ficar boa. Eu me sinto cada dia pior, mas não posso decepcioná-los. Eles fazem tudo por mim”.

Muitas vezes, a criança precisa de alguém com quem falar sobre a morte. Morrer dói? O que acontece quando a gente morre? Essas são perguntas para as quais não temos respostas, mas podemos tranquilizar a criança, assegurando-lhe de que estará acompanhada e sendo cuidada.

A CRIANÇA VÍTIMA DE MAUS-TRATOS

Embora ocorram há séculos, os maus-tratos contra crianças tornaram-se amplamente reconhecidos apenas a partir dos anos de 1960, com a descrição da síndrome da criança espancada (*battered-child syndrome*), feita pelo pediatra americano C. Henry Kempe. Como tema atual e de extrema importância, a violência contra crianças adquiriu proporções alarmantes no último século, tornando-se um grave problema de saúde pública.³³

A maioria das definições de maus-tratos incorpora dois elementos centrais: a evidência de comportamento prejudicial em relação à criança e a presença de danos resultantes dessa conduta. Os maus-tratos contra crianças compreendem o abuso (físico, emocional e sexual) e a negligência (física, emocional e educacional). A essas formas de maus-tratos, poderiam ser acrescentados os maus-tratos sociais, que envolvem a esfera social e institucional, como exploração do trabalho infantil ou tráfico de crianças, prostituição infantil, não oferecimento de políticas básicas igualitárias e oportunidades de participação social e alimentação.³⁴

Crianças vítimas de abuso têm mais chance de desenvolver comportamento impulsivo, transtorno de estresse pós-traumático (TEPT), transtorno de déficit de atenção/hiperatividade, problemas de aprendizagem, bem como transtorno da conduta, abuso de substâncias psicoativas na adolescência, além de prejuízos cognitivos. Crianças que sofreram abuso terão maior propensão para abusar de seus filhos quando se tornarem adultas.^{35,36}

Experiências de violência ocorrida durante a infância podem interferir de modo significativo no desenvolvimento da criança, produzindo desde comportamentos de não adaptação e déficits emocionais até transtornos mentais graves.³⁷

Alguns fatores têm sido relacionados à ocorrência de maus-tratos na infância:

1. condições sociais desfavoráveis, como pobreza, promiscuidade, rede de apoio médico e social deficitária, desemprego e condições ruins de moradia
2. famílias com privação econômica, relações desarmônicas, pais separados e baixo nível de escolaridade dos pais
3. famílias nas quais os pais abusadores ou negligentes foram abusados ou negligenciados na infância
4. pais (ou responsáveis) usuários de substâncias psicoativas
5. pais (ou responsáveis) com transtornos psiquiátricos, como transtornos da personalidade, depressão ou psicose
6. fatores infantis: nascimento prematuro, deficiência intelectual, sexo masculino, ser adotado ou estar vivendo em abrigo ou em medidas socioeducativas

Exame físico de crianças vítimas de abuso físico

Frequentemente, os ferimentos presentes em uma criança vítima de maus-tratos mostram-se mais graves do que seria de se esperar em relação às causas declaradas pelos responsáveis (p. ex.,

ruptura do baço, fratura de clavícula, escoriações no rosto e vergões nas costas, quando os responsáveis afirmam que ela caiu acidentalmente enquanto brincava).³⁸

Lesões como hematomas, contusões, vergões ou mesmo queimaduras no corpo estão entre os sinais de abuso físico (Quadro 11.1). Em geral, as lesões seguem um padrão similar nas diferentes áreas corporais afetadas, podendo, inclusive, indicar o formato do objeto utilizado para provocar o ferimento, como marcas de fios elétricos, fivelas de cintos, dentes ou as próprias mãos do agressor.

QUADRO 11.1

Sinais físicos de abuso em crianças

Contusões e vergões:

- rosto, lábios, boca, orelhas, olhos, pescoço, cabeça, tronco, costas, nádegas, coxas, mãos, pés

Queimaduras:

- por cigarro: sola dos pés, palma das mãos, costas ou nádegas
- por imersão: especialmente nas extremidades, nádegas ou genitais
- por aparelhos elétricos, utensílios domésticos (como ferro de passar, panelas quentes, tostador) ou moldadas pelo cordão (qualquer parte do corpo)

Fraturas: em geral, múltiplas

- nariz, crânio, costelas, ossos longos

Lacerações ou escoriações

Contusões:

- principalmente na parede abdominal

Lesões em órgãos internos/visceras:

- hematomas intramurais de duodeno ou jejuno, perfuração intestinal, ruptura de fígado, baço, rins, bexiga ou veias

Lesões no SNC:

- mais frequentemente hematoma subdural, hemorragia retinal, hemorragia subaracnoide

NEGLIGÊNCIA

A negligência de uma criança pode ser definida como uma condição em que seus cuidadores provocam dano físico ou emocional devido à omissão dos cuidados necessários para seu desenvolvimento e equilíbrio, sendo que essa falha não é resultado de condições de vida que fogem ao seu controle.

Assim, se uma criança está desnutrida porque há falta de dinheiro para obter o alimento, não se trata de uma situação de negligência. Negligência ocorre, por exemplo, se os pais utilizam o dinheiro da alimentação da criança para outros fins, como consumo de drogas ou jogos.

A negligência pode ser física, emocional ou educacional. Uma ampla lista de condutas e situações pode ser classificada como negligência em relação a uma criança:

1. falha ou recusa a oferecer tratamento de saúde à criança
2. abandono, ou mesmo desatenção, em relação a riscos a que a criança se encontra exposta
3. descuidos com alimentação, vestimenta ou higiene
4. comportamentos perigosos dos pais, como dirigir em alta velocidade ou embriagado
5. pais que abandonam ou expulsam a criança de casa
6. pais que permitem repetidas ausências da criança à escola ou que não matriculam seus filhos, não conferem lições de casa ou não fornecem o material didático exigido pela escola
7. pais que expõem seus filhos a situações conjugais estressantes: brigas do casal, uso de drogas diante dos filhos
8. pais que expõem a criança a comportamentos de risco, como mendicância, consumo de substâncias psicoativas, etc.
9. manifestações inadequadas de afeto por parte dos pais

ABUSO SEXUAL

O abuso sexual infantil é uma das formas mais graves de maus-tratos praticados contra a criança. Sua ocorrência pode produzir diversas marcas no corpo e no psiquismo infantil, incidindo também sobre a dinâmica familiar.

O abuso sexual pode ser definido como uma situação em que a criança ou o adolescente é utilizado para a satisfação sexual de um adulto ou de outra criança maior ou adolescente, podendo incluir carícias, manipulação de genitália, mamas ou região anal, exploração sexual, *voyeurismo*, exibicionismo, abusos verbais (conversas abertas sobre atividades sexuais com a finalidade de despertar o interesse sexual da criança), pornografia e até o ato sexual com ou sem penetração.

O abuso sexual infantil supõe disfunção nos três seguintes níveis: poder exercido pelo grande (forte) sobre o pequeno (fraco), confiança que o pequeno (dependente) tem no grande (protetor) e, por fim, o uso delinquente da sexualidade, ou seja, o atentado ao direito básico que todo ser humano tem de propriedade sobre seu próprio corpo.

Diferentemente de outras formas de violência, o abuso sexual tem por finalidade a satisfação perversa do abusador, despertando precocemente na criança sensações de natureza sexual profundamente perturbadoras.

Crianças vítimas de abuso sexual podem ser hospitalizadas em uma enfermaria de pediatria. Tais situações costumam mobilizar intensamente a equipe pediátrica, e a presença do psiquiatra infantil poderá ser necessária.³⁹

Frequentemente praticado sem o uso da força física, o abuso sexual pode não deixar marcas visíveis, dificultando sua comprovação. O relato da criança, especialmente as muito pequenas, poderá ser tomado como fantasioso. Muitas vezes, a criança não confirma a história de abuso narrada inicialmente, o que pode gerar dúvidas na equipe pediátrica. Cabe ao grupo da pediatria, muitas vezes, com ajuda do interconsultor psiquiátrico, dar crédito às afirmações da criança.

A revelação do abuso e a possibilidade de a criança receber algum tipo de ajuda podem ser demoradas. Crianças vítimas de abuso sexual têm dificuldades em se abrir em relação a essa questão com o médico que lhes presta atendimento. Em muitos casos, será necessária a utilização de meios de comunicação não verbal, como desenhos ou o brincar.

Na maior parte das vezes, as crianças abusadas são trazidas ao serviço de emergência com outras queixas, muitas vezes conduzidas pelo próprio abusador. Quando o abuso é praticado por algum membro da família da criança, ela poderá ser proibida de revelar o ocorrido, sofrendo, inclusive, ameaças. A maioria dos casos de abuso sexual é praticada por pessoas da família da criança ou próximas a ela. A familiaridade do abusador com a criança cria condições que favorecem a prática do abuso.

Como a queixa de abuso sexual não é frequente, o médico deve estar atento a sintomas e sinais sugestivos de que a criança tenha sofrido alguma forma de violência sexual. O Quadro 11.2 destaca alguns indicadores sugestivos da ocorrência de abuso sexual.

QUADRO 11.2

Sinais e sintomas sugestivos de abuso sexual na infância

- Dor, prurido ou irritação nos órgãos genitais ou na via urinária
- Desconforto da criança ao sentar ou caminhar
- Presença de doenças sexualmente transmissíveis
- Comportamentos como irritabilidade, agressividade com outras crianças, manipulação excessiva dos órgãos genitais, brincadeiras frequentes de caráter sexual, ansiedade, depressão, choro sem motivo aparente, mutismo, dificuldades escolares, etc.

SÍNDROME DE MÜNCHAUSEN POR PROCURAÇÃO

A síndrome de Münchausen por procuração é uma doença psiquiátrica descrita recentemente, na qual uma pessoa (em geral a mãe da criança) inventa sintomas de uma doença qualquer, de modo que a criança passa a ser considerada doente. Para que seus filhos pareçam doentes, as mães podem relatar falsos sintomas, falsear exames ou até mesmo produzir danos físicos à criança.

O nome da doença faz alusão à síndrome de Münchausen, relatada em 1951, por Asher, que descreveu adultos que fabricavam sintomas de doenças, ludibriando médicos e submetendo-se a procedimentos clínicos, e até mesmo cirúrgicos, desnecessários. A referência original é ao barão von Münchausen, de Hanover, que viveu no século XVIII, tornando-se famoso ao narrar histórias cheias de exagero e fantasia sobre suas aventuras na guerra contra os turcos.

Na síndrome de Münchausen por procuração, descrita, em 1977, pelo pediatra britânico Richard Meadow, a criança apresenta-se repetidamente com sintomas que, na verdade, são produzidos pelos pais e acabam resultando em numerosos procedimentos médicos na criança (tratamentos e até mesmo cirurgias desnecessárias). Em geral, as vítimas são crianças em idade pré-escolar, mas a síndrome pode vitimar crianças maiores ou bebês.

Os sintomas físicos mais comuns produzidos na criança são convulsões, sangramentos, apneia, vômitos, diarreia, cefaleia, exantemas e depressão do sistema nervoso central. Com a finalidade de produzir os sintomas na criança, os pais poderão realizar certas manobras, como adulterar exames laboratoriais, trocar amostras para exame, provocar constipação ou administrar laxantes, administrar drogas indutoras de vômito, induzir bacteremia por exposição da criança a material contaminado, adulterar dados do termômetro, envenenar, administrar medicamentos e sufocar, produzindo parada cardiorrespiratória.

Entre os medicamentos mais utilizados pelos abusadores, estão benzodiazepínicos, anticonvulsivantes, aspirina, antidepressivos, insulina, antieméticos e codeína. A possibilidade de verificar a dosagem sérica desses medicamentos na sala de emergência pode ajudar no diagnóstico. Em geral, o perpetrador do quadro tem conhecimento de medicina, o que ajuda no relato dos sintomas da falsa doença.

A detecção da síndrome de Münchausen por procuração não é uma tarefa fácil para o médico. Alguns sinais podem ajudar na detecção do quadro. Geralmente, trata-se de uma doença incomum, que não pode ser substanciada ou facilmente descartada pelo médico.

A criança pode não aparentar estar doente ou não confirmar as queixas formuladas pelos cuidadores. Além disso, os tratamentos que, em geral, são eficazes para uma determinada doença costumam não ter efeito sobre a doença relatada. Geralmente, a criança já passou por várias avaliações, em diferentes serviços médicos.⁴⁰

MANEJO DO ABUSO E DA NEGLIGÊNCIA NA INFÂNCIA E NA ADOLESCÊNCIA

Diante da suspeita de que uma criança tenha sofrido abuso ou negligência, o médico deve iniciar rigorosa investigação, necessitando, muitas vezes, da ajuda de outros familiares, professores ou até mesmo vizinhos da criança.⁴¹ Várias condutas deverão ser adotadas, considerando-se sempre o aspecto multidimensional da violência praticada. Assim, a conduta deverá levar em conta os cuidadores, a criança e as características socioeconômicas e culturais do grupo ao qual ela pertence. O Quadro 11.3 indica possíveis formas de manejo diante de uma criança vítima de maus-tratos.

QUADRO 11.3

Manejo da criança vítima de abuso ou negligência

- Realizar entrevistas com todos os membros da família, procurando, inclusive, descartar patologias psiquiátricas ou uso de drogas pelos cuidadores
- Realizar avaliações individuais com a criança, incluindo testes psicológicos ou hora de jogo
- Fazer exame físico minucioso da criança, procurando indícios de lesões (queimaduras, hematomas, vergões, etc.)
- Realizar exame neurológico para descartar lesões no sistema nervoso central
- Estar atento a sintomas psíquicos recentes e sem causa bem definida, como tristeza, irritabilidade, ideação suicida, comportamento agressivo, recusa em ir à escola, etc.
- Realizar exame dos órgãos genitais e da região anal, com coleta de secreção (especialmente quando há suspeita de abuso sexual)
- Realizar exames de radioimagem (especialmente em casos com suspeita de fraturas)
- Realizar exames laboratoriais, como sorologias para doenças sexualmente transmissíveis, teste de gravidez
- Encaminhar para a perícia, quando a gravidade da situação indicar
- Realizar entrevista com profissionais e pessoas do grupo social (vizinhos, parentes, amigos)
- Contatar órgão judicial responsável para a notificação do abuso
- Verificar a possibilidade do retorno da criança ao lar de origem ou a necessidade de internação hospitalar ou institucional
- Prover tratamento físico e psicológico para a criança e o(s) agressor(es)

Crianças vítimas de abuso ou negligência devem receber tratamento médico e psicológico. O tratamento psicoterápico para a criança, bem como para o agressor, tem sido o mais indicado. O profissional da saúde também deve estar atento ao papel do meio ambiente, devendo buscar os recursos da sociedade (conselho tutelar, juizado da infância e juventude, assistência social ou instituições oficiais ou não governamentais de defesa da criança).

O encaminhamento da criança a um lar abrigado poderá ser necessário, com suspensão da guarda dos pais. Os pais abusadores também poderão demandar atendimento psicológico e psiquiátrico, durante e após a internação.

ASPECTOS TÉCNICOS DA INTERCONSULTA COM CRIANÇAS

A atenção do interconsultor deve abranger três níveis: a criança, sua família e a dinâmica da enfermaria de pediatria.

A criança é um ser em desenvolvimento, e, ao avaliá-la hospitalizada, o interconsultor tem apenas um instantâneo da vida dela e de um momento estressante. Seu estado atual só pode realmente ser compreendido a partir do conhecimento de seu comportamento e funcionamento anteriores à doença e à hospitalização. Por isso, em geral, o primeiro contato do interconsultor é realizado com os pais, que irão fornecer um relato detalhado da história de vida e familiar da criança, de seu desenvolvimento e de sua doença.

Faz parte da função do interconsultor tentar compreender a criança e sua família a partir de uma visão mais ampla, sendo a doença mais um dos vários desafios que a criança e sua família devem enfrentar durante seu processo de desenvolvimento.

Cabe ao interconsultor auxiliar a equipe de enfermaria a compreender o significado psicológico da conduta da criança e da reação de seus pais. Para avaliar como as dificuldades físicas e emocionais da criança são vivenciadas pela equipe de enfermaria, é útil, para o interconsultor, voltar sua atenção para o conjunto de pacientes da unidade de internação, as mortes recentes e outros traumas, as atitudes da equipe em relação a certas doenças e a identificação de membros da equipe psicologicamente mais vulneráveis.

A partir das informações obtidas com a equipe pediátrica e com os pais, o interconsultor deverá avaliar diretamente a criança. Para tanto, poderá utilizar brinquedos e material gráfico. Após a avaliação desses três níveis, o interconsultor poderá realizar uma avaliação e um diagnóstico mais amplo e acurado da situação da criança, ou seja, um *diagnóstico situacional*. Poderá, então, planejar sua conduta terapêutica, que visará, acima de tudo, à comunicação rápida, efetiva e de qualidade entre os membros da equipe de saúde.

O resultado do processo de interconsulta deverá ser comunicado verbalmente aos membros da equipe que cuidam da criança, em ocasião apropriada para discussões e questionamentos. Após essa fase, devem ser registrados, no prontuário da criança, um resumo do motivo do pedido de interconsulta, o relato da história da criança, o exame psíquico, uma formulação diagnóstica e a conduta sugerida, incluindo sugestões de manejo aliadas às devidas justificativas. Consideramos que o jargão profissional deva ser evitado a todo custo, bem como especulações e suposições. Cabe ao interconsultor ater-se aos fatos e sobre eles emitir sua opinião especializada, estando sempre atento aos cuidados éticos e legais.

Alguns aspectos gerais ligados à hospitalização que devem ser objeto de interesse do interconsultor são:

1. Manter a qualidade dos vínculos afetivos entre os pais e a criança hospitalizada. A permanência de um dos pais junto à criança durante a hospitalização deve ser considerada o princípio central da assistência psicológica. Além disso, cabe ao interconsultor ser capaz de diferenciar depressão, patologias de personalidade e dificuldades de ajustamento. Crianças com condições médicas que interferem na alimentação, que limitam a possibilidade de os

cuidadores pegarem-na no colo, que afetam a aparência ou que deixam a criança muito irritável constituem um verdadeiro desafio para o desenvolvimento de vínculos. Essas situações requerem dos pais grande maturidade emocional, uma vez que provocam sentimentos de impotência e incompetência, facilmente vividos como falta de amor da criança por eles. É aqui que a equipe médica pode desempenhar um papel importantíssimo, auxiliando e apoiando emocionalmente os cuidadores.

2. Possibilitar a crianças em idade pré-escolar adaptação mais saudável a sua doença e às intervenções que se fizerem necessárias. Para isso, a dor deve ser controlada ou eliminada sempre que possível. Os procedimentos devem ser explicados em termos simples, levando-se em consideração o nível de compreensão da criança. Deve-se explicar o que vai ser feito, qual a razão do procedimento e se este pode ser desconfortável ou doloroso. A criança deve também ser informada sobre onde seus pais irão estar durante e após o procedimento.
3. É importante que haja na enfermaria da pediatria um lugar onde a criança se sinta a salvo, isto é, um lugar onde ela saiba que nenhum procedimento é executado, onde ela possa brincar ou executar atividades apropriadas para sua idade e condição física. Tais atividades podem servir como um contraponto aos mecanismos regressivos próprios do adoecer e da hospitalização.
4. Além disso, a criança deve ser informada, com antecedência, sobre qualquer procedimento a que será submetida. Isso favorece sua confiança, evitando que se mantenha constantemente em estado de alerta à espera de um “ataque surpresa”.

MODALIDADES DE TRATAMENTO

Os transtornos psiquiátricos da infância podem ser abordados por uma ampla gama de modalidades terapêuticas, incluindo a prescrição de psicofármacos, a psicoterapia (psicodinâmica, de grupos, cognitivo-comportamental e de família) e/ou o manejo do ambiente em que a criança vive.

Cabe ao psiquiatra conhecer os diferentes procedimentos terapêuticos e saber optar pelo mais adequado para cada situação em particular, sendo capaz de realizar os encaminhamentos quando perceber que o paciente se beneficiaria de um enfoque terapêutico que o médico não domina tecnicamente.

A **psicoterapia psicanalítica**, isolada ou associada a outras formas de tratamento, é muito empregada em uma série de transtornos mentais na infância. Nessa modalidade de tratamento, a criança utiliza comunicação verbal, além de elementos lúdicos (o brincar e o material gráfico) e dramáticos, para estabelecer um relacionamento com um adulto que a aceita e a auxilia a compreender e esclarecer suas experiências subjetivas.

Pedro, um menino de 10 anos de idade, é levado ao hospital, após tentar suicídio ingerindo veneno para matar ratos. Na consulta pediátrica, recusa-se a falar sobre o ocorrido. Apresenta humor deprimido e mantém a ideia suicida. A família é desestruturada e monoparental. O menino não conheceu o pai biológico. Todos os dias, Pedro tem de tomar conta dos quatro irmãos menores, frutos de outros relacionamentos da mãe, com parceiros diferentes. Durante a hospitalização, ao ser abordado pelo psiquiatra infantil, mantém seu comportamento reticente, mas aceita fazer desenhos.

O primeiro desenho da criança (Fig. 11.1) mostra um jogo de futebol, no momento em que um jogador vai bater o pênalti. O desenho chama a atenção pela grande desproporção entre o tamanho do jogador que baterá o pênalti e o goleiro, bem menor e sem braços.

O segundo desenho (Fig. 11.2) é feito dois meses após o início do tratamento (psicoterapia psicodinâmica individual associada a tratamento farmacológico, com antidepressivo ISRS).

A criança apresenta expressiva melhora. O humor está eufórico, e os pensamentos de suicídio desapareceram. Pedro está em um abrigo, pois a mãe perdeu temporariamente a guarda dos filhos, por negligência. Ele vem à consulta acompanhado da cuidadora do abrigo, com quem demonstra grande entrosamento e afeto.

Ele faz um segundo desenho, um barco, e conta a seguinte história: “o barco é muito seguro e está ancorado em um rio de águas muito tranquilas. Ao lado do rio, existe uma perigosa cachoeira, de águas muito fortes. Entretanto, a âncora do barco é segura e mais forte ainda do que a temida cachoeira. Além disso, existem boias salva-vidas. O piloto é muito experiente, e as pessoas do barco, todas muito amigas, podem se alimentar dos vários peixes que habitam essas águas calmas e cristalinas”.

Claramente, Pedro demonstra em seus desenhos o que não consegue comunicar em palavras. Ele não tinha defesas saudáveis para lidar com suas dificuldades, abrindo-se, assim, a porta para o comportamento suicida. Após o tratamento, Pedro está mais estruturado. O barco ancorado (abrigo) lhe oferece proteção. Existem pessoas confiáveis lhe ajudando a conduzir a vida. O alimento para o psiquismo traz de volta o desejo pela vida.

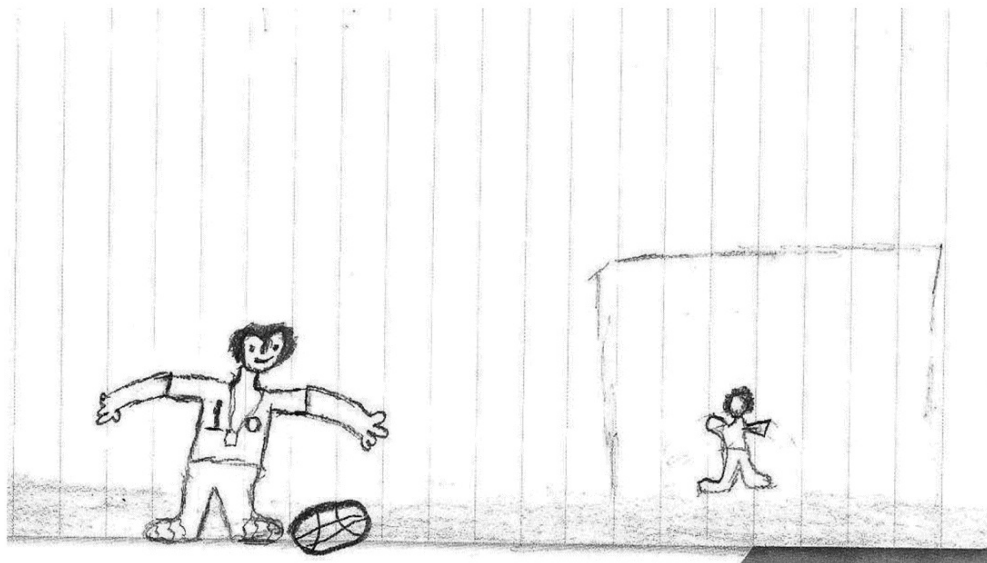


FIGURA 11.1 Pedro, 10 anos. O goleiro sem braços: um menino sem defesas.



FIGURA 11.2 Pedro, 10 anos. O barco ancorado: um porto seguro.

A **psicoterapia cognitivo-comportamental** integra teorias de cognição e aprendizagem. Pressupõe que variáveis cognitivas, emocionais e comportamentais estão inter-relacionadas. Vale-se de reestruturação cognitiva e de técnicas comportamentais para obter mudanças. A criança é ensinada e encorajada a desenvolver comportamentos novos e mais adaptados, aprendendo a prever as consequências, manejar contingências, estabelecer estratégias e soluções alternativas.

Muitas crianças poderão necessitar também de **tratamento psicofarmacológico**.^{42,43} As doses médias das medicações são determinadas empiricamente, tomando como base os princípios farmacológicos do adulto. No entanto, o conhecimento dos fundamentos da farmacologia

evolutiva é um requisito necessário para a administração segura e eficaz de medicamentos psicotrópicos em crianças e adolescentes.

O tratamento psicofarmacológico desenvolvido para uso adulto exige modificações quando utilizado para o tratamento de transtornos psiquiátricos em indivíduos cujo corpo e o cérebro ainda se encontram em desenvolvimento.^{44,45}

Assim, com relação à psicofarmacologia evolutiva, algumas noções fundamentais são:

1. Crianças e adolescentes requerem proporções de dose por quilo maiores do que os adultos, a fim de alcançarem níveis plasmáticos e efeitos terapêuticos comparáveis. Isso se deve a maior metabolização hepática, maior filtração glomerular e menor quantidade de tecido adiposo.
2. Diferenças substanciais na distribuição de fármacos são observadas em crianças e adolescentes. Entre os fatores físicos que podem influenciar, encontram-se o tecido adiposo e o tamanho dos compartimentos de água, o débito cardíaco, a perfusão sanguínea regional, a pressão de perfusão dos órgãos, a permeabilidade das membranas celulares, o equilíbrio acidobásico e a ligação a proteínas plasmáticas e teciduais. Cada um desses fatores pode mudar ao longo do desenvolvimento, resultando em alterações na distribuição da droga e, subsequentemente, no efeito farmacológico.
3. O desenvolvimento bioquímico do cérebro continua até o fim da adolescência e início da vida adulta. Considerando que o desenvolvimento neuroquímico persiste por toda a vida, é impossível determinar uma idade a partir da qual os fármacos possam ser seguros em relação ao desenvolvimento do cérebro e do corpo. Entretanto, a clínica tem mostrado que o cérebro e o corpo da criança não são mais sensíveis aos efeitos colaterais das drogas psicotrópicas do que os dos adultos. No entanto, não se pode dizer o mesmo a respeito de sua eficácia. Mesmo assim, é importante ressaltar que os medicamentos psicotrópicos só devem ser usados em crianças após o relato extenso de sua utilização em adultos. Tal medida visa diminuir o risco de toxicidade sobre o desenvolvimento.⁴⁶

Os potenciais benefícios da droga devem justificar os riscos concomitantes a sua administração. Devemos levar em conta principalmente o diagnóstico, uma vez que o mesmo sintoma pode estar presente em diferentes patologias (p. ex., hiperatividade como parte da sintomatologia do transtorno de déficit de atenção/hiperatividade; hiperatividade como parte da sintomatologia de uma criança autista ou com transtorno invasivo da personalidade).

O uso dos psicofármacos deve ser parte de um tratamento mais amplo e raramente uma modalidade única de tratamento. É fundamental a psicoeducação da criança e de seus pais sobre o uso da medicação, o que aumenta as chances de adesão e uso adequado.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

O psiquiatra que trabalha com interconsulta desempenha um importante papel na formação e no treinamento de pediatras, residentes de pediatria, estudantes de medicina e enfermagem, enfermeiros e outros membros da equipe. Não é incomum encontrarmos pediatras com interesse substancial em questões psicossociais. A questão que se coloca é o que e como ensinar.

É pelo desenvolvimento de uma relação de confiança e empatia entre a equipe da enfermaria de pediatria e o psiquiatra interconsultor que o treinamento em relação às questões de diagnóstico e tratamento psiquiátrico de crianças doentes e de suas famílias pode se realizar.

Essa relação de confiança tem mais possibilidades de ocorrer, mesmo levando-se em conta as inúmeras diferenças entre as especialidades, com a presença frequente do psiquiatra infantil durante as visitas à enfermaria. É durante as discussões do caso que o psiquiatra poderá perceber as dificuldades psicológicas da criança, de seus familiares e da equipe assistencial, podendo, assim, ajudar no projeto terapêutico.

REFERÊNCIAS

1. Bakr A, Amr M, Sarhan A, Hammad A, Ragab M, El-Refaey A, et al. Psychiatric disorders in children with chronic renal failure. *Pediatr Nephrol*. 2007;22(1):128-31.
2. Todaro JF, Fennell EB, Sears SF, Rodrigue JR, Roche AK. Review: cognitive and psychological outcomes in pediatric heart transplantation. *J Pediatr Psychol*. 2000;25(8):567-76.
3. Thapar A, Pine DS, Leckman JF, Scott S, Snowling MJ, Taylor EA. *Rutter's child and adolescent psychiatry*. 6th ed. New York: John Wiley & Sons; 2015.
4. DeMaso DR, Martini DR, Cahen LA, Bukstein O, Walter HJ, Benson S, et al. Practice parameter for the psychiatric assessment and management of physically ill children and adolescents. *J Am Acad Child Adolesc Psychiatry*. 2009;48(2):213-33.
5. Oguz A, Kurul S, Dirik E. Relationship of epilepsy-related factors to anxiety and depression scores in epileptic children. *J Child Neurol*. 2002;17(1):37-40.
6. Kazak AE, Barakat LP, Meeske K, Christakis D, Meadows AT, Casey R, et al. Posttraumatic stress symptoms, family functioning, and social support in survivors of childhood leukemia and their mothers and fathers. *J Consult Clin Psychol*. 1997;65(1):120-9.
7. Kazak AE, Simms S, Rourke M. Family systems practice in pediatric psychology. *J Pediatr Psychol*. 2002;27(2):133-43.
8. Freud S. Três ensaios sobre a teoria da sexualidade. In: Freud S. *Obras psicológicas completas de Sigmund Freud*. 2. ed. Rio de Janeiro: Imago; 1987.
9. Klein M. A psicanálise de crianças. In: *Obras completas de Melanie Klein*. Rio de Janeiro: Imago; 1997.
10. Spitz AR. Hospitalism: an inquiry into the genesis of psychiatric conditions in early childhood. *Psychoanal Study Child*. 1945;1:53-74.
11. Bowlby J. *Cuidados maternos e saúde mental*. São Paulo: Martins Fontes; 1951.
12. Robertson J, Bowlby J. *A two-year-old goes to hospital: the psychoanalytic study of child*. London: New York University Film; 1952.
13. Freud A. The role of bodily illness in the mental life of children. *Psychoanal Study Child*. 1952;7:69-81.
14. Shaw RJ, Wamboldt M, Bursch B, Stuber M. Practice patterns in pediatric consultation-liaison psychiatry: a national survey. *Psychosomatics*. 2006;47(1):43-9.
15. Knapp P, Harris ES. Consultation-liaison in child psychiatry: a review of the past 10 years. Part I: clinical findings. *J Am Acad Child Adolesc Psychiatry*. 1998;37(1):17-25.
16. Stern TA, Rosenbaum JF, Fava M, Biederman J, Rauch SL. *Massachusetts general hospital comprehensive clinical psychiatry*. Philadelphia: Elsevier; 2015.
18. Carter BD, Kronenberger WG, Baker J, Grimes LM, Crabtree VM, Smith C, et al. Inpatient pediatric consultation-liaison: a case-controlled study. *J Pediatr Psychol*. 2003;28(6):423-32.

19. Campbell J, Cardona L. The consultation and liaison processes to pediatrics. In: Martin A, Volkmar FR, Lewis M, editors. Child and adolescent psychiatry: a comprehensive textbook. Philadelphia: Lippincott Williams & Wilkins; 2007. p. 692-700.
20. Rothenberg MB. Child psychiatry consultation-liaison services in the hospital setting: a review. *Gen Hosp Psychiatry*. 1979;1(4):281-6.
21. Rauch P, Jellinek M. Pediatric consultation. *Arch Dis Child*. 2003;88(12):1139.
22. Bursch B, Stuber MD. Pediatrics. In: Levenson J, editor. The American Psychiatric publishing textbook of psychosomatic medicine psychiatric care of the medically III . 2nd ed. Geneva: APA; 2011. p. 827- 54.
23. Garralda ME, Bailey D. Psychiatric disorders in general pediatric referrals. *Arch Dis Child*. 1989;64(12):1727-33.
24. Bowman FM, Garralda ME. Psychiatric morbidity among children who are frequent attenders in general practice. *Br J Gen Pract*. 1993;43(366):6-9.
25. Kashani J, Hakami N. Depression in children and adolescents with malignancy. *Can J Psychiatry*. 1982;27(6):474-7.
26. Best M, Streisand R, Catania L, Kazak AE. Parental distress during pediatric leukemia and parental posttraumatic stress symptoms after treatment ends. *J Pediatr Psychol*. 2001;26(5):299-307.
27. Augé M. Ordre biologique, ordre social: la maladie, forme élémentaire de l'événement. In: Augé M, Herslich C, editors. *Le sens du mal: antropologie, histoire, sociologie de la maladie*. Paris: Éditions des Archives Contemporaines; 1991.
28. Herslich C. Médecine moderne et quête de sens: la maladie signifian social. In: Augé M, Herslich C, editors. *Le sens du mal: antropologie, histoire, sociologie de la maladie*. Paris: Éditions des Archives Contemporaines; 1991.
29. Crepaldi MA. Hospitalização na infância: representações sociais da família sobre a doença e a hospitalização de seus filhos em Unidade de Pediatria [tese]. Campinas: Faculdade de Ciências Médicas, UNICAMP; 1995.
30. Jellinek MS, Herzog DB, editors. *Paediatric consultation*. Chicago: Year Book; 1990.
31. Erickson SJ, Steiner H. Trauma spectrum adaptation: somatic symptoms in long-term pediatric cancer survivors. *Psychosomatics*. 2000; 41(4):339-46.
32. Perina EM, Nucci N. As dimensões do cuidar em psiconcologia pediátrica: desafios e descobertas. Campinas: Livro Pleno; 2005. Vol. 1.
33. Kempe CH, Silverman FN, Steele BF, Droegemueller W, Silver HK. The battered child Syndrome. *JAMA*. 1962;181:17-24.
34. Kauffman J. Child abuse and neglect. In: Martin A, Volkmar FR, Lewis M, editors. Child and adolescent psychiatry: a comprehensive textbook. Philadelphia: Lippincott Williams & Wilkins; 2007. p. 692-700.
35. Aded NLO, Dalcin BLGS, Moraes TM, Cavalcanti MT. Sexual abuse in children and adolescents: review of 100 years of literature. *Arch Clin Psychiatry*. 2006;33(4):204-13.

36. Kaufman J, Zigler E. Do abused children become abusive parents? *Am J Orthopsychiatry*. 1987;57(2):186-92.
37. Messman-Moore T, Brown AL. Child maltreatment and perceived family environment as risk for adult rape: is child abuse the most salient experiences? *Child Abuse Negl*. 2004;28(10): 1019-34.
38. Berkowitz CD. Pediatric abuse: new patterns of injury. *Emerg Med Clin North Am*. 1995;13(2):321-41.
39. Glayser D. Child sexual abuse. In: Rutter M, Taylor E. *Child and adolescent psychiatry* 4th ed. New York: Blackwell; 2004. p. 340-58.
40. Forsyth BWC, Asnes AG. Munchausen syndrome by proxy. In: Martin A, Volkmar FR, Lewis M, editors. *Child and adolescent psychiatry: a comprehensive textbook*. Philadelphia: Lippincott Williams & Wilkins; 2007. p. 719-26.
41. Browne K. Child Protection. In: Rutter M, Taylor E. *Child and adolescent psychiatry* 4th ed. New York: Blackwell; 2004. p. 529-54.
42. White JH. *Psicofarmacologia pediátrica: um guia prático para aplicação clínica*. São Paulo: Manole; 1979.
43. Wiener JM. *Diagnosis and psychopharmacology of childhood and adolescence*. New York: John Wiley; 1996.
44. Stephen S. *Stahl's essential psychopharmacology: neuroscientific basis and practical applications*. 4th ed. Cambridge: Cambridge University; 2013.
45. Martin A, Scahill L, Kratochvil C, editors. *Pediatric psychopharmacology*. 2nd ed. Oxford: Oxford University; 2011.
46. Findling RL. *Clinical manual of child and adolescent psychopharmacology*. Arlington: APA; 2008.



O paciente com transtorno mental grave

Cláudio E. M. Banzato

Paulo Dalgalarrrondo

Entre os inúmeros problemas e desafios enfrentados por pacientes com transtornos mentais graves, o cuidado adequado com a saúde física é particularmente negligenciado por familiares e profissionais da saúde. Não é raro que tais pacientes sejam vistos e tratados como uma classe especial de pessoas, integralmente definidas por certos aspectos psíquicos ou mentais, cuja abordagem médica, independentemente da natureza do problema de saúde em questão, estaria sempre circunscrita à esfera Psi. Essa percepção equivocada e deficiente não poderia estar mais afastada da realidade, pois a morbidade clínico-cirúrgica e a mortalidade precoce desses pacientes são consideravelmente elevadas. Neste capítulo, relata-se a experiência do HC-Unicamp, adquirida ao longo de 30 anos, combinando aspectos psiquiátricos, clínicos e cirúrgicos no cuidado aos pacientes internados na Unidade de Internação Psiquiátrica.

MORBIDADE E MORTALIDADE DE PACIENTES COM TRANSTORNOS MENTAIS GRAVES

Segundo dados do Global Burden of Disease (GBD) de 2010, os transtornos mentais em geral são responsáveis por 8,6 milhões de anos de vida perdidos em mortalidade prematura.^{1,2} O excesso de mortalidade não resulta apenas de maiores taxas de suicídio, mas também de uma combinação de variáveis socioeconômicas, da atenção à saúde e de fatores de riscos clínicos.³ Estima-se que o risco de mortalidade (por todas as causas) conferido pela esquizofrenia e pelo transtorno bipolar (TB) seja muito similar àquele representado pelo do tabagismo contumaz.¹

Esquizofrenia e TB são os exemplos mais proeminentes do que aqui denominamos transtornos mentais graves (TMG). Os Quadros 12.1 e 12.2 apresentam uma sinopse dos critérios diagnósticos dessas patologias. Outras condições, como a depressão grave, alguns casos de dependência química, de anorexia nervosa e psicose secundária a doenças não psiquiátricas e seus tratamentos, incluem-se entre os TMG frequentemente encontrados no hospital geral.

QUADRO 12.1

Critérios diagnósticos para esquizofrenia, segundo o DSM-5

- A. Exige-se que dois (ou mais) dos itens a seguir estejam presentes por boa parte do tempo por um período de um mês (menos, se tratados com sucesso). Pelo menos um deles deve ser (1), (2) ou (3):
 - 1. Delírios.
 - 2. Alucinações.
 - 3. Discurso desorganizado.
 - 4. Comportamento grosseiramente desorganizado ou catatônico.
 - 5. Sintomas negativos (i.e., expressão emocional diminuída ou diminuição da vontade – avolia).
- B. Deve haver prejuízo no nível de funcionamento (p. ex., trabalho, relações interpessoais, cuidados consigo mesmo).
- C. Os sinais do transtorno devem persistir por pelo menos seis meses (pelo menos um mês dos sintomas 1 a 4).

Fonte: Com base em American Psychiatric Association.⁴

QUADRO 12.2

Critérios diagnósticos para transtorno afetivo bipolar, segundo o DSM-5

Definição de episódio maniaco

- A. Presença de humor anormal e persistentemente elevado, expansivo ou irritável, e aumento anormal e persistente de atividades. Estar anormalmente com “muita energia”, com duração mínima de uma semana e na maior parte do dia, quase todos os dias (ou qualquer duração, se a hospitalização se fizer necessária).
- B. Durante o período de perturbação, três (ou mais) dos seguintes sintomas (quatro se o humor é apenas irritável) estão presentes em grau significativo e representam uma mudança notável do comportamento habitual da pessoa:
 - 1. Autoestima inflada ou grandiosidade.
 - 2. Redução da necessidade de sono.
 - 3. Muito falante; mais loquaz que o habitual ou pressão para continuar falando.
 - 4. Pensamento acelerado e muito fluente, podendo revelar associações pelo som da palavra ou por motivos contingenciais (fuga de ideias).
 - 5. Distratibilidade (i.e., a atenção é desviada muito facilmente por estímulos externos insignificantes ou irrelevantes).
 - 6. Aumento importante da atividade ou agitação psicomotora.
 - 7. Envolvimento excessivo em atividades com elevado potencial para consequências dolorosas ou problemáticas (p. ex., envolvimento em surtos desenfreados de compras, indiscrições sexuais ou investimentos financeiros insensatos).
- C. A perturbação do humor é suficientemente grave a ponto de causar prejuízo acentuado no funcionamento social ou profissional ou requerer hospitalização, ou existem características psicóticas.
- D. O episódio não é atribuível aos efeitos fisiológicos de uma substância ou a outra condição médica.

Notas:

- Um episódio maníaco completo que surge durante tratamento antidepressivo (p. ex., medicamento, eletroconvulsoterapia), mas que persiste em um nível de sinais e sintomas além do efeito fisiológico desse tratamento, é suficiente para um episódio maníaco.
- Pelo menos um episódio maníaco na vida é necessário para o diagnóstico de transtorno bipolar tipo I.

Definição de transtorno bipolar tipo I

- E. Foram atendidos os critérios para pelo menos um episódio maníaco (Critérios A-D, em “Episódio Maníaco”, descritos acima).
- F. A ocorrência do(s) episódio(s) maníaco(s) e depressivo(s) maior(es) não é mais bem explicada por transtorno esquizoafetivo, esquizofrenia, transtorno esquizofreniforme, transtorno delirante ou transtorno do espectro da esquizofrenia e outro transtorno psicótico com outras especificações ou não especificado.

Definição de episódio hipomaniaco

- G. Humor anormal e persistentemente elevado, expansivo ou irritável e aumento anormal e persistente da atividade ou energia, com duração mínima de quatro dias consecutivos e presente na maior parte do dia, quase todos os dias.
- H. Durante o período de perturbação, três (ou mais) dos seguintes sintomas (quatro se o humor é apenas irritável) persistem e representam uma mudança notável em relação ao comportamento habitual:
1. Autoestima inflada ou grandiosidade.
 2. Redução da necessidade de sono.
 3. Mais falante e loquaz que o habitual ou pressão para continuar falando.
 4. Pensamento acelerado e muito fluente, podendo revelar associações pelo som da palavra ou por motivos contingenciais (fuga de ideias).
 5. Distratibilidade (i.e., a atenção é desviada muito facilmente por estímulos externos insignificantes ou irrelevantes).
 6. Aumento importante da atividade ou agitação psicomotora.
 7. Envolvimento excessivo em atividades com elevado potencial para consequências dolorosas ou problemáticas (p. ex., envolvimento em surtos desenfreados de compras, indiscrições sexuais ou investimentos financeiros insensatos).
- I. O episódio está associado a uma mudança clara no funcionamento que não é característica do indivíduo quando assintomático.

Definição de transtorno bipolar tipo II

- J. Foram atendidos os critérios para pelo menos um episódio hipomaniaco.
- K. Jamais houve um episódio maníaco.
- L. A ocorrência do(s) episódio(s) hipomaniaco(s) e depressivo(s) maior(es) não é mais bem explicada por transtorno esquizoafetivo, esquizofrenia, transtorno esquizofreniforme, transtorno delirante, outro transtorno do espectro da esquizofrenia e outro transtorno psicótico especificado ou transtorno do espectro da esquizofrenia e outro transtorno psicótico não especificado.
- M. Os sintomas de depressão ou a imprevisibilidade causada por alternância frequente entre períodos de depressão e hipomania causam sofrimento clinicamente significativo ou prejuízo no funcionamento social, profissional ou em outra área importante da vida do indivíduo.

Fonte: Com base em American Psychiatric Association.⁴

Os altos níveis de morbidade clínico-cirúrgica dos pacientes que sofrem de TMG, combinados com as múltiplas barreiras enfrentadas para o acesso ao cuidado apropriado, têm como consequência a mortalidade precoce, que lamentavelmente é a regra nesse grupo. Essa mortalidade prematura é um fato conhecido de longa data e muito bem documentado por estudos epidemiológicos, revisões sistemáticas e metanálises recentes.^{1,5-9}

Considerando apenas as pessoas com esquizofrenia, a defasagem de longevidade em relação à população em geral varia entre 10 e 25 anos.⁶ Um grande estudo de coorte sueco estimou tal mortalidade prematura de pacientes com esquizofrenia em 15 anos para homens e 12 anos para mulheres, lembrando que a Suécia é um país desenvolvido em relação ao cuidado de saúde universal para a população.⁷

Comparando-se estudos de diferentes períodos, constata-se que a expectativa de vida tem aumentado para os pacientes com TMG, mas muito menos do que para a população em geral. Como consequência, a diferença entre esses dois grupos só tem-se ampliado ao longo das últimas décadas.⁸

Nos pacientes com TMG, a mortalidade por conta de causas não naturais (externas) é maior do que na população em geral, sobretudo por conta do suicídio.¹⁰ No entanto, a imensa maioria de pacientes com TMG morre de causas naturais, segundo um padrão que não difere substancialmente daquele apresentado pela população em geral.^{3,7} No estudo sueco citado, as principais causas de óbito entre indivíduos com esquizofrenia foram doença isquêmica cardíaca e

câncer.⁷ As doenças cardiovasculares também predominam entre as principais causas de morte prematura de pessoas acometidas por TB.¹¹

Considerando o conjunto de todos os transtornos mentais, em termos do excesso de mortalidade, as doenças cardiovasculares responderiam por 30%, enquanto o câncer (em torno de 13%) teria impacto equivalente ao do suicídio.⁸

O Quadro 12.3 apresenta as condições e doenças associadas aos TMG, entre as quais se destacam diabetes, hiperlipidemia, doença cardiovascular, hipertensão arterial sistêmica, obesidade, câncer e HIV/aids.¹² Em parte, é preciso reconhecer que os efeitos colaterais dos psicofármacos contribuem para o surgimento ou agravamento de algumas dessas condições.^{10,12} Contudo, há evidências, no caso da esquizofrenia, de que a falta de tratamento com antipsicóticos associa-se a maior mortalidade por suicídio e câncer.⁷ Além disso, é necessário reconhecer um importante fator ambiental que contribui para a maior morbimortalidade de indivíduos com TMG: a tendência a um estilo de vida pouco saudável, com dieta pobre em nutrientes, tabagismo, consumo excessivo de álcool e sedentarismo.^{6,9,10}

QUADRO 12.3

Condições físicas e doenças frequentes na população de pessoas com TMG e suas relações com o transtorno mental, os psicofármacos e estilos de vida

Diabetes tipo II, resistência à insulina e anormalidades da regulação da glicemia

- Estilos de vida relacionados: dieta inadequada, sedentarismo
- Psicofármacos: todos os antipsicóticos (atípicos – principalmente olanzapina, clozapina e risperidona – mais que típicos) aumentam a probabilidade de desenvolver diabetes tipo II
- Risco aumentado em pessoas com esquizofrenia

Dislipidemia, hiperlipidemia

- Os antipsicóticos (sobretudo os atípicos) aumentam o risco de se desenvolver dislipidemia (tanto por mecanismos associados ao ganho de peso como por mecanismos não associados ao ganho de peso)
- Alguns antipsicóticos típicos (p. ex., haloperidol) não têm efeitos no metabolismo lipídico; fenotiazinas (p. ex. clorpromazina) tendem a aumentar o nível de triglicerídeos e reduzir os níveis de lipoproteínas de alta densidade
- Antipsicóticos atípicos dibenzodiazepínicos (p. ex., clozapina, olanzapina), em comparação com risperidona, estão associados a níveis aumentados da glicose e de lipídeos em jejum

Doenças cardiovasculares (hipertensão arterial, arritmias cardíacas)

- Antipsicóticos (principalmente atípicos) estão associados a síndrome metabólica (hipertensão, hiperlipidemia, hiperglicemia, resistência à insulina e obesidade)
- O estilo de vida de pessoas com TMG (tabagismo, alcoolismo, dietas inadequadas, sedentarismo) contribui para o risco aumentado de problemas cardíacos
- Mortalidade por doença isquêmica cardíaca, arritmias cardíacas e infarto do miocárdio é significativamente elevada em pessoas com TMG
- Pessoas com esquizofrenia têm taxas aumentadas de doenças cardiovasculares e respiratórias quando comparadas à população em geral

Obesidade

- Antipsicóticos atípicos dibenzodiazepínicos (p. ex., clozapina e olanzapina) estão associados a rápido aumento do peso, no curto prazo (primeiros 3-6 meses do tratamento). No longo prazo, a diferença entre as classes de antipsicóticos é menos clara
- Estilo de vida e menor habilidade em mudar comportamentos também contribuem para a obesidade e o sobrepeso
- 40 a 62% das pessoas com esquizofrenia têm obesidade ou sobrepeso

Neoplasias malignas

- Pessoas com esquizofrenia têm maior chance de desenvolver câncer, e, tendo câncer, esse grupo tem 50% menos chance de sobrevivência
- Parecem existir diferenças para tipos de câncer: as mulheres com esquizofrenia têm mais chance de desenvolver câncer de mama; os homens, menos chance de desenvolver câncer de pulmão

HIV/aids

- A incidência de HIV/aids em pessoas com esquizofrenia (estimada em 4-23%) parece ser maior do que na população em geral. Fatores para isso seriam menor frequência de sexo seguro e uso de substâncias injetáveis e não injetáveis

Hepatite C

- Prevalência aumentada em pessoas com esquizofrenia em relação à população em geral

Osteoporose

- A ocorrência mais precoce de osteoporose em pessoas com esquizofrenia tem sido atribuída a níveis mais baixos de estrogênio e testosterona pela ação dos antipsicóticos, níveis de cálcio diminuídos devido a tabagismo e alcoolismo, e polidipsia (mais frequentemente encontrada em esquizofrenia crônica do que na população em geral)

Hiperprolactinemia

- Doses altas de antipsicóticos típicos e atípicos (p. ex., risperidona e amisulprida) elevam os níveis de prolactina, causando galactorreia, amenorreia, oligomenorreia, disfunção sexual e densidade óssea diminuída. A hiperprolactinemia contribui também para doença cardiovascular.

Outras doenças físicas

- A incidência de síndrome do cólon irritável em pessoas com esquizofrenia é de 19% (em comparação a 2,5% na população em geral)
- A prevalência de infecção por *Helicobacter pylori* é significativamente aumentada em pessoas com esquizofrenia (risco relativo = 3,0)

Fonte: Com base em Lambert e colaboradores.¹²

No período compreendido entre 1987 e 2004, dos 2.233 pacientes internados na Unidade de Internação Psiquiátrica (UIP) do HC-Unicamp, 26 foram a óbito.¹³ A média de idade dos pacientes que faleceram foi de 47,2 anos, e os principais diagnósticos psiquiátricos foram transtornos do humor e esquizofrenia. Em 54% dos casos, as mortes ocorreram por doenças cardiorrespiratórias.¹³

Em suma, a alta morbidade clínica de pacientes com TMG tem causas variadas que se potencializam reciprocamente para produzir esse efeito. Entre elas, encontram-se:

- insuficiência de cuidados próprios (perda de iniciativa, de autonomia e do pragmatismo provocada pelo transtorno)
- nutrição inadequada e/ou padrões alimentares deletérios influenciados pela própria psicopatologia
- hábitos que estão comumente associados ao transtorno, como sedentarismo e tabagismo
- condições que resultam da combinação de efeitos indiretos do transtorno, hábitos e efeitos colaterais do tratamento farmacológico, como a obesidade e a síndrome metabólica
- sequelas de lesões autoprovocadas e/ou tentativas de suicídio
- inúmeras barreiras de acesso a tratamentos de saúde

No caso das barreiras, o problema começa com a própria autopercepção corporal. Não é raro observarmos negligência dos pacientes com alterações mórbidas em seu próprio corpo ou mesmo com uma percepção corporal delirante. Assim, nem sempre há queixas para os familiares e procura de um serviço de saúde. Da parte da família, por falta de iniciativa, mas, muitas vezes, também por falta de orientação dos psiquiatras e das equipes de saúde mental, os pacientes com TMG não fazem controles clínicos e laboratoriais preventivos (medição de pressão arterial, glicemia, colesterol e triglicerídeos) e outros procedimentos rotineiros de *screening*, considerando faixa etária e gênero, preconizados para a população em geral. Bons exemplos disso são a ida anual ao ginecologista, com a realização do exame preventivo Papanicolau, no caso de pacientes do sexo feminino, e a ida periódica ao urologista para exame de próstata em homens com mais de 45 anos. É importante acrescentar, ainda, a precária saúde bucal que é muitas vezes constatada, pela combinação de cuidados insuficientes e falta de tratamento odontológico.

BARREIRAS DE ACESSO AO DIAGNÓSTICO E AO TRATAMENTO NOS SERVIÇOS DE SAÚDE

A lamentável perda precoce de vidas tem, entre seus determinantes, fatores extrínsecos aos pacientes ou a seus transtornos mentais, sendo de grande importância (e modificável, por excelência) a qualidade do cuidado em saúde recebido por essa subpopulação. As evidências sugerem que os indivíduos com TMG, a despeito do contato mais frequente com os serviços de saúde, recebem cuidado inferior àquele dispensado à população em geral – eles não são incluídos, rotineiramente, em programas preventivos e, quando apresentam condições clínicas gerais, com frequência, são subdiagnosticados e subtratados ou diagnosticados tardiamente (com as complicações decorrentes do atraso).^{6 7}

Apesar da elevada comorbidade, a detecção de doenças físicas é baixa em pacientes com TMG.¹² No Quadro 12.4, são listados os diversos fatores que prejudicam o acesso desses pacientes ao cuidado integral à saúde, e, no Quadro 12.5, são apresentadas sugestões de ações para minimizar tais barreiras.

QUADRO 12.4

Barreiras ao reconhecimento e manejo adequado de condições clínicas gerais em pacientes com TMG

Paciente

- Autopercepção deficiente de alterações corporais
- Maior tolerância à dor ou a desconfortos relacionados aos transtornos mentais ou ao uso de psicofármacos que modificam a sensibilidade e/ou expressão
- Linguagem em que as queixas são formuladas pode fornecer poucas pistas sobre o que está acontecendo
- Atribuição das queixas/alterações aos próprios problemas mentais (às vezes, de forma delirante) pode mascarar certas condições clínicas
- Falta de iniciativa para procurar serviços de saúde
- Entendimento falho das recomendações por conta de limitações cognitivas relacionadas aos transtornos mentais
- Dificuldades executivas que podem comprometer a adesão ao tratamento

Família

- Preocupação exclusiva com aspectos mentais e comportamentais do paciente
- Negligência com medidas preventivas de rotina em serviços de saúde (p. ex., no caso de mulheres, ida anual ao ginecologista)
- Tolerância maior com hábitos prejudiciais à saúde

Profissionais da saúde

- Compartimentalização do cuidado: separação (ou falta de integração adequada entre) da RAPS das UBS e PSF
- Falta de estruturas adaptadas para a realização de certos procedimentos em pacientes com necessidades especiais
- Não realização frequente de exame físico por parte dos psiquiatras
- Falta de consideração e de monitoramento do impacto dos efeitos colaterais deletérios dos psicofármacos
- Formação médica na área de psiquiatria muitas vezes é deficiente
- Atribuição apressada e incorreta, por parte de clínicos generalistas e especialistas, de queixas somáticas aos transtornos mentais de base (subdiagnóstico)
- Estigma: indisposição de médicos não psiquiatras em tratar indivíduos com transtornos mentais graves (por conta do preconceito de que seriam pacientes difíceis, complicados, não cooperativos – ou, ainda pior, menos merecedores de cuidados)
- Falta de empenho de clínicos generalistas e especialistas para realizar o tratamento padrão oferecido àqueles que não apresentam transtornos mentais (subtratamento)

TMG = transtornos mentais graves

RAPS = Rede de Atenção Psicossocial

UBS = Unidade Básica de Saúde

PSF = Programa de Saúde da Família

QUADRO 12.5

Problemas e ações em saúde física em pessoas com TMG

Problemas e questões de pessoas com TMG	Ações da equipe de saúde geral	Ações da equipe de saúde mental
Negligência com o próprio corpo	- Realizar exame físico cuidadoso, lembrando que são pacientes que às vezes informam mal - Incentivar o paciente a observar seu corpo	- Perguntar atentamente ao paciente sobre seu funcionamento corporal - Realizar procedimentos educativos para um melhor contato com o corpo
Hábitos alimentares inadequados Obesidade	Orientar o paciente quanto a nutrição a partir da perspectiva da medicina geral	- Incluir avaliação de peso, altura e nutrição no seguimento em saúde mental - Procurar substituir psicofármacos que estejam produzindo significativo ganho de peso
Deteção e rastreamento de condições físicas frequentes	Utilizar rigorosamente os mesmos procedimentos que são empregados para a população em geral	Incluir na rotina da saúde mental procedimentos de rastreamento de saúde geral (p. ex., medir pressão arterial, solicitar glicemia, PSA, TSH, etc.)
Tabagismo	- Utilizar as mesmas abordagens empregadas para a população em geral - Não aceitar a ideia errônea “fumar é o único prazer dele...”	Instituir programas e ações para reduzir tabagismo como parte das ações em saúde mental
Uso e abuso de bebidas alcoólicas e outras substâncias	A partir de dados somáticos, alertar para os riscos do uso e para os benefícios do controle	Investigar ativamente o uso/dependência de álcool e outras substâncias
Receio em procurar profissionais e serviços de saúde geral	- Colocar-se de forma receptiva diante de pessoas com TMG - Reduzir medos e receios direcionados à medicina geral	Encorajar a busca e procurar fazer encaminhamentos para profissionais e serviços mais flexíveis e acolhedores
Discriminação produzindo barreiras para acesso a serviços/procedimentos de saúde geral	Prestar mais atenção a possíveis discriminações “automáticas” na rotina do cuidado a pessoas com TMG	Engajamento sobre direitos e combate claro e incisivo à discriminação dos pacientes com TMG

TMG = transtorno mental grave

PSA = antígeno prostático específico

TSH = hormônio estimulador da tireoide

O que é preocupante em especial é a discriminação (que pode ter consequências letais) sofrida pelos indivíduos com TMG por parte de médicos e outros profissionais da saúde – frequentemente são tratados como se fossem menos dignos ou merecedores da atenção à saúde em relação às demais pessoas.³ Adicionalmente, dito de outro modo, o investimento e o esforço necessários para atender às demandas e às necessidades desses indivíduos não compensam. Nesse sentido, o combate ao estigma e ao preconceito é fundamental para que a meta de cuidado de saúde em termos de igualdade e equidade seja atingida no tratamento de indivíduos com TMG.

Ainda sobre as barreiras no interior dos próprios serviços de saúde, que devem sua existência, em larga medida, ao estigma contra os chamados “pacientes psiquiátricos”, encontra-se um exemplo trivial, mas bastante revelador, desse estado de coisas: os pacientes psiquiátricos de uma unidade básica de saúde localizada em um grande centro metropolitano têm um prontuário clínico separado, diferente daqueles dos demais usuários, que, com frequência, só é lido e alimentado por profissionais da saúde mental. Outro exemplo bastante significativo é a existência de portas separadas em serviços de urgência para atendimento de pacientes com TMG, que são utilizadas independentemente da condição que motiva a busca do atendimento. É como

se a presença de um TMG definisse por completo as pessoas diagnosticadas e fizesse elas se transformarem em uma categoria à parte de pessoas que – e isso é assumido inadvertidamente – estariam imunes a outras doenças. Isso é exatamente o contrário do que acontece na realidade, em que problemas físicos e mentais se retroalimentam.

Duas atitudes (não excludentes entre si) são observadas constantemente em serviços de saúde: a primeira consiste em considerar o paciente psiquiátrico como alguém menos digno ou menos merecedor de cuidados, em quem não compensa investir do ponto de vista médico; a segunda corresponde a enxergar nele somente um paciente difícil, recalcitrante ou mesmo intratável. Com frequência, psiquiatras que trabalham em hospitais gerais são consultados por colegas de outras especialidades que querem saber se pacientes com TMG (muitas vezes, compensados clinicamente, seguidos de forma regular em serviços ambulatoriais de saúde mental/CAPS) podem ser submetidos a tratamentos para condições clínicas graves, como neoplasias, cujo tratamento combina intervenções cirúrgicas, radioterapia ou quimioterapia, ou fraturas que requeiram cirurgias ortopédicas, seguidas de períodos de imobilização, etc.

É preciso modificar radicalmente a percepção que dá origem a esse tipo de consulta. Ao perguntar-se se é possível, deve-se responder “sim, é possível e desejável!”. Portanto, a pergunta a ser feita deve ser “como fazer?”, isto é, como integrar o trabalho de clínicos, cirurgiões e psiquiatras em benefício desses pacientes, que se encontram, por razões psiquiátricas e médicas gerais, tão vulneráveis.

BARREIRAS EM GRANDES CIRURGIAS: OS EXEMPLOS DOS TRANSPLANTES DE ÓRGÃOS E DAS CIRURGIAS BARIÁTRICAS

Devido ao fato de pessoas com TMG apresentarem morbidade e mortalidade significativamente superiores em relação à população em geral, elas necessitam, com frequência relativamente maior, de certas intervenções médicas, incluindo-se as de grande complexidade, como transplantes de órgãos (rins, fígado, coração, pulmões, medula óssea, etc.) e cirurgia bariátrica por obesidade. Esta última é marcadamente mais frequente em TMG do que na população em geral.

De modo geral, os protocolos de transplantes de órgãos e de cirurgia bariátrica contraindicam relativa ou absolutamente tais procedimentos em pessoas com TMG.¹⁴ Por exemplo, nas últimas décadas, estima-se que por volta de 90% dos centros de transplante de órgãos nos Estados Unidos consideravam a esquizofrenia clinicamente presente (*active schizophrenia*) uma contraindicação absoluta para transplante de órgãos. Além disso, a esquizofrenia, mesmo estando clinicamente controlada e compensada, foi considerada contraindicação absoluta para transplante de órgãos em 51% das unidades de transplante cardíaco, 65% das unidades de transplante hepático e em 62% das unidades de transplante renal. Portanto, cabe notar que 74% dos centros de transplante consideravam a deficiência intelectual, incluindo a leve (QI entre 55 e 70), uma contraindicação absoluta para transplantes.^{15,16}

Os TMG também têm sido considerados contraindicação relativa ou absoluta (variando de centro para centro) para as cirurgias bariátricas. De modo geral, o diagnóstico de esquizofrenia com sintomas clínicos presentes tem sido contraindicação absoluta para as cirurgias bariátricas. Os pacientes acometidos por TMG, mesmo estabilizados, representam um percentual muito pequeno entre as pessoas que passam por tais cirurgias.¹⁷

Os centros que realizam transplantes e cirurgias bariátricas consideram, de forma justificada, que esses procedimentos necessitam de adesão muito rigorosa aos acompanhamentos e tratamentos médicos, como o uso de imunossupressores para os transplantes e a reposição de vitaminas e nutrientes nas cirurgias bariátricas. Os pacientes com TMG não seriam bons candidatos a tais procedimentos, pois não teriam condições de consentir livremente para tanto nem de seguir os protocolos exigentes de tais centros e não teriam, de modo geral, boa adesão ao tratamento. Além disso, o estresse do transplante ou da cirurgia bariátrica e os efeitos neurotóxicos das medicações imunossupressoras (como os corticosteroides e outras) conduziriam tais pacientes a recaídas psiquiátricas e ao fracasso do procedimento.¹⁸

Apesar dessa preocupação, algumas pessoas com TMG têm recebido transplantes de órgãos, e tem-se verificado que, quando recebem atenção médica, psiquiátrica e psicológica adequadas, demonstram evolução semelhante à da população sem transtornos mentais. Os poucos estudos disponíveis sobre transplantes em pessoas com TMG indicam que, quando psiquiatricamente compensadas, em um meio social e familiar estável, elas tendem a apresentar um padrão de evolução semelhante ao de grupos sem TMG.^{18,19}

Da mesma forma que para os transplantes, as cirurgias bariátricas têm sido realizadas em um número pequeno, porém crescente, de pessoas com TMG. Tem-se observado e documentado, por

meio de séries de casos relatados, que tais cirurgias para tratar a obesidade mórbida podem ser realizadas com sucesso em pessoas com TMG. Além disso, quando adequadamente selecionadas e acompanhadas, tais pessoas apresentam evolução semelhante à da população em geral, com perda de peso e melhora da qualidade de vida também equivalentes.²⁰

Portanto, a não inclusão sistemática e a obstrução de acesso a procedimentos de complexidade médica, como transplantes e cirurgias bariátricas, podem ser explicadas mais por preconceito e discriminação arraigados no público em geral e em profissionais da saúde do que por uma avaliação realista de riscos. Psiquiatras, psicólogos clínicos e demais profissionais de saúde mental, sobretudo aqueles que atuam em hospitais gerais, devem agir como uma espécie de “defensores públicos” de seus pacientes com TMG, para que estes possam obter os mesmos benefícios da medicina de alta complexidade que as demais pessoas da população em geral. Certamente, pacientes com TMG francamente descompensados e clinicamente muito comprometidos não seriam candidatos a tais procedimentos, mas há um grande contingente de pessoas com TMG estabilizado do ponto de vista psicossocial e clínico que deve ser tratado igualitariamente e ter acesso garantido a todos os recursos que as pessoas sem TMG têm.

Embora riscos cirúrgicos maiores tenham sido constatados em pacientes com esquizofrenia,²¹ alguns fatores que contribuem para o aumento da taxa de complicações também já foram identificados, como a demora no diagnóstico e no tratamento, a interação medicamentosa entre analgésicos, anestésicos e medicações psiquiátricas, a falta de treinamento adequado dos profissionais para a comunicação com e o manejo dos pacientes com esquizofrenia, que podem, por exemplo, ter um limiar maior para dor ou um repertório diferente para manifestação de queixas somáticas.²¹

CONSENTIMENTO PARA INTERVENÇÕES E PROCEDIMENTOS

Uma questão que preocupa médicos e demais profissionais da saúde que tratam de quadros clínicos e cirúrgicos graves de pacientes com TMG é a do consentimento para a realização de intervenções e procedimentos. O primeiro ponto que deve ficar claro é que, na avaliação da capacidade de consentir, o diagnóstico psiquiátrico é apenas um dos elementos a ser considerado.

Uma pessoa com diagnóstico de esquizofrenia preservada cognitivamente e que esteja compensada ou fora de um episódio psicótico tem plena capacidade de consentir. No entanto, na vigência de uma depressão psicótica, um indivíduo até então completamente funcional pode perder temporariamente a capacidade de decidir sobre os rumos de seu tratamento. Não raro observamos delírios niilistas ou de ruína em pacientes deprimidos graves, que consideram ociosas quaisquer tentativas de aliviar seu sofrimento (alguns, com síndrome de Cotard, chegam inclusive a se sentir mortos).

Quadros muito prevalentes em hospitais gerais, como *delirium* ou confusão mental, independentemente da etiologia, também são bastante incapacitantes. Em outros termos, a condição momentânea do paciente (i.e., seu estado mental, que engloba cognição, estado basal de humor e relação com a realidade) é muito mais importante para a avaliação de sua capacidade de consentir do que seu diagnóstico psiquiátrico de base. Isso significa que a avaliação da capacidade não deve ser estanque; o paciente pode e deve ser objeto de intervenções terapêuticas voltadas para as alterações de seu estado mental.

Na UIP do HC-Unicamp, inúmeros pacientes foram tratados psiquiatricamente, com psicofármacos (incluindo a clozapina) ou eletroconvulsoterapia (ECT), antes da realização de cirurgias eletivas de grande porte ou de intervenções de maior impacto, como quimioterapia. Nesse sentido, o psiquiatra também tem bastante a contribuir para que o paciente com TMG participe ativamente das decisões sobre os rumos dos tratamentos médicos para suas condições comórbidas.

Em relação à clozapina e à ECT, por sua reconhecida efetividade e pela frequência de seu uso em pacientes com TMG que acorrem a hospitais gerais, incluem-se as considerações dos Quadros 12.6 e 12.7.

QUADRO 12.6

Algumas considerações sobre o tratamento com a clozapina

- A remissão total dos sintomas e o pleno restabelecimento da funcionalidade devem ser as metas do tratamento da esquizofrenia, sobretudo nos primeiros episódios psicóticos.
- A clozapina é o padrão-ouro no tratamento farmacológico da esquizofrenia refratária (que constitui cerca de 30% dos casos de esquizofrenia).
- Apesar de ser o padrão-ouro no tratamento farmacológico da esquizofrenia refratária, a clozapina é largamente subutilizada em muitos serviços de saúde mental no Brasil.²²
- No tratamento de um episódio psicótico, é preciso ter em mente desde o início que uma eventual progressão do antipsicótico para a clozapina pode ser necessária.
- A falta de resposta mínima a um antipsicótico após 2-4 semanas de uso regular e correto prediz falha terapêutica e justifica a troca da medicação antipsicótica.
- A clozapina pode ser usada como segunda ou terceira medicação antipsicótica já no tratamento de um primeiro episódio psicótico.
- O uso da clozapina ainda pode ser antecipado em casos de risco de suicídio elevado, estupor ou, ainda, presença de sintomas extrapiramidais importantes.
- Antes de iniciar o uso da clozapina, realizar hemograma completo e ECG (atenção especial para o intervalo QT) e pesquisar antecedentes de crises convulsivas, inclusive convulsões febris na infância.
- É necessário realizar hemogramas semanais nas primeiras 18 semanas de tratamento e, a partir de então, hemogramas mensais indefinidamente, enquanto persistir o uso da clozapina.

- Os pacientes e seus familiares devem ser orientados a procurar um pronto-socorro em caso de febre.
- Muitas das complicações relacionadas ao uso da clozapina estão associadas à velocidade de sua introdução. Em geral, incrementos de 25 mg a cada 2-3 dias são bem tolerados. A partir de 200 mg/dia, aumentar 50 mg por semana.
- Se possível, evitar o uso concomitante de drogas que inibem o citocromo P450 (sobretudo a enzima 1A2).
- Enquanto se progride a dosagem da clozapina, reduzir gradualmente a dose do antipsicótico anterior, com sua suspensão considerada quando a clozapina estiver em 200 mg/dia, se o estado clínico do paciente permitir.
- Leucocitose com desvio à esquerda acentuado não é infrequente no início do tratamento e é um indicador de mielotoxicidade. Nesses casos, considerar redução da velocidade da progressão de dose, aumento da frequência dos hemogramas (a cada 2-3 dias) e introdução de ácido fólico (5 mg/dia) na prescrição.
- Em caso de taquicardia persistente no repouso, com dor no peito ou dispneia, considerar a possibilidade de miocardite pela clozapina, complicação que é mais comum nos primeiros dois meses de uso.
- Embora alguns pacientes respondam bem a doses baixas (até 200 mg/dia), a maioria requer doses mínimas de 300-400 mg/dia.
- A decisão de parar em 300-400 mg/dia e aguardar a resposta a essa dose por algumas semanas ou prosseguir para patamares mais elevados, como 500-600 mg/dia ou, ainda, 700-900 mg/dia, deve ser tomada com base na resposta clínica, na tolerabilidade e na presença de efeitos colaterais.
- Se doses maiores que 400 mg/dia forem necessárias, é interessante realizar um eletrencefalograma (EEG). Alterações inespecíficas no EEG estarão presentes em quase todos os casos. O que importa é a presença de alterações epileptiformes (p. ex., espículas, pontas, espículas-ondas lentas), sobretudo as frequentes. Se isso for constatado, considerar o uso concomitante de um anticonvulsivante, como o ácido valproico.
- Lembrar que o valor preditivo positivo do EEG é maior do que seu valor preditivo negativo. Ou seja, um EEG dentro da normalidade não exclui a possibilidade de crises convulsivas.
- Com doses a partir de 500-600 mg/dia, o risco de crises convulsivas é elevado (em torno de 20-25%).
- Sonolência e sialorreia são os efeitos colaterais comuns que mais costumam incomodar os pacientes. Ambos tendem a melhorar com o tempo.
- O ganho de peso com clozapina é considerável, sobretudo nos meses iniciais do tratamento, podendo causar com frequência sobrepeso ou obesidade e suas consequências. Nesse período, insistir com o paciente e a família para que adotem hábito alimentar o mais saudável possível (como o consumo de alimentos com poucas calorias e muitas fibras), cuidar bem da hidratação (sede pode ser confundida com fome) e evitem itens como chocolate, sorvetes, doces, biscoitos e bolachas, frituras, carne gordurosa.

QUADRO 12.7

Algumas considerações sobre a eletroconvulsoterapia (ECT)

- Poucos procedimentos médicos são tão cercados de controvérsias e preconceitos quanto a ECT. Sua imagem pública e no meio médico é, de modo geral, bastante negativa e profundamente distorcida da realidade atual. Ela é muito pouco disponível no Brasil, tanto nos serviços públicos como nos privados.
- A ECT é um tratamento marcadamente eficaz e seguro (em comparação aos psicofármacos), se bem indicado e realizado de acordo com as normas técnicas.
- As principais indicações para ECT são síndrome de estupor (incluindo a catatonia), depressão grave refratária, mania refratária.
- A ECT constitui o padrão-ouro no tratamento da depressão psicótica, da depressão refratária e da síndrome de estupor.
- A ECT também pode ser utilizada no tratamento da síndrome neuroléptica maligna e da esquizofrenia, em quadros com muita agitação e/ou desorganização ou, ainda, como adjuvante à clozapina em casos super-refratários.
- O consentimento esclarecido do próprio paciente (quando possível) e/ou dos responsáveis deve ser obtido antes de se iniciar a ECT. A saúde bucal e as condições dos dentes devem ser avaliadas, pois dentes desvitalizados fraturam com certa frequência, mesmo com protetores bucais.
- Antes da realização da ECT, o paciente deve ser avaliado clinicamente, com atenção particular para sua condição cardíaca.
- A principal contraindicação para a ECT é a presença de hipertensão intracraniana.
- Outras condições que aumentam os riscos da ECT e que, portanto, demandam maior cuidado são hipertensão arterial grave, história recente de AVC ou IAM e a existência de fatores de risco para hemorragia intracraniana.
- As sessões de ECT acontecem, em geral, em dias alternados.
- Em média, são necessárias 8 a 12 sessões de ECT em cada tratamento.
- O critério utilizado para interrupção das sessões de ECT é a constatação de um *plateau* no nível de resposta clínica, isto é, 2 ou 3 sessões consecutivas sem ganho terapêutico adicional.
- O efeito colateral mais comum da ECT é a alteração temporária de memória. Cefaleia, náuseas e confusão mental transitória também podem ocorrer.
- Em virtude da lacuna e da desproporção entre a marcante eficácia e segurança relativa *versus* a má imagem pública e no meio médico, o profissional de saúde mental deve estar bem informado sobre a ECT e atuar como educador, desmistificando e mostrando os aspectos realistas relacionados a essa importante ferramenta terapêutica.

ABORDAGENS SIMULTÂNEAS EM DUAS FRENTES

Uma situação encontrada com frequência em hospitais gerais ilustra a dificuldade dos profissionais da saúde de modo geral em trabalhar simultaneamente em duas frentes, a médico geral e a psiquiátrica. Essa situação é observada, por exemplo, em casos de síndrome consumptiva – pacientes com importante emagrecimento e eventual desnutrição que se apresentam muito combalidos, desanimados e sem energia. Em casos mais avançados, os pacientes permanecem acamados, exibindo lentificação psicomotora global.

Evidentemente, é imperativo que o médico investigue a presença de condições como neoplasias, quadros infecciosos ou alterações metabólicas, que são alguns exemplos de doenças mais comuns. No entanto, não se deve negligenciar ou deixar apenas para um segundo momento a pesquisa de sinais e sintomas de depressão, que pode ser primária ou secundária a outra condição médica de base. O fato é que a presença de um quadro depressivo, independentemente de ser primário ou secundário, impõe medidas terapêuticas específicas.

Em nossa experiência, muitas vezes, a melhora clínica geral de um paciente com patologias graves e depressão passa, em grande parte, pela recuperação de sua vontade, ânimo e disposição. Por isso, entendemos que a investigação diagnóstica deve sempre ser abrangente, englobando, ao mesmo tempo, a busca de causas médicas gerais e psiquiátricas. Dessa maneira, deve-se reconhecer que elas não são mutuamente excludentes, mas a coexistência de condições médicas gerais e psiquiátricas é a regra, e não a exceção. Afinal, uma aumenta a vulnerabilidade para a outra. Portanto, além do reconhecimento dessas comorbidades, é preciso intervir em cada uma das condições presentes para que o desfecho terapêutico seja positivo.

Dois casos clínicos emblemáticos de pacientes atendidos em nossa UIP do HC-Unicamp exemplificam essa abordagem em duas frentes. O primeiro deles é o de uma paciente de 46 anos com delírio estruturado de uma gravidez de trigêmeos há sete anos. Ela foi hospitalizada com um índice de massa corporal (IMC) de 10,8, e, segundo ela, “os trigêmeos, que estranhamente não nascem, estão pressionando seu estômago”, o que impediria sua alimentação normal, provocando vômitos recorrentes. O diagnóstico psiquiátrico inicial de transtorno delirante foi mudado posteriormente para esquizofrenia, pelo declínio funcional observado. Durante a internação, além do tratamento com clozapina (até 200 mg/dia) para o quadro psicótico, a investigação clínica encontrou uma dilatação esofágica, o que levou ao diagnóstico de acalasia. A paciente foi submetida a uma intervenção cirúrgica laparoscópica bem-sucedida para a acalasia, foi renutrida gradualmente e teve alta hospitalar com IMC de 13,37. Meses depois, em acompanhamento ambulatorial, seu IMC chegou a 21,27.²³

O segundo caso é o de uma paciente de 45 anos, com longa história de anorexia nervosa e, nos últimos anos, de etilismo, que chega ao pronto-socorro do HC-Unicamp desnutrida (IMC = 16,42), com confusão mental, marcha atáxica e oftalmoplegia. Os exames laboratoriais mostraram que o magnésio sérico estava baixo e que havia anemia megaloblástica. Foi diagnosticada uma síndrome de Wernicke-Korsakoff, e foi iniciada a reposição imediata de tiamina e magnésio. Dias após a admissão hospitalar, o estado confusional agudo remitiu, e a paciente foi renutrida gradualmente durante a internação. Infelizmente, a paciente persistiu com déficits de memória meses após a alta hospitalar,²⁴ entretanto, acredita-se que seu déficit teria

sido possivelmente bem mais pronunciado caso não tivesse recebido tratamento médico adequado.

Um estudo recente mostrou o impacto muito significativo das intervenções coordenadas, facilitadas pelo gerenciamento ativo da comunicação e das ações de educação e saúde. Tais fatores conseguem transpor as barreiras existentes, melhorando, assim, a qualidade e os resultados da atenção médica primária em pacientes com TMG.²⁵ Se não existe saúde sem saúde mental, o contrário também é verdadeiro: não existe saúde mental sem a saúde do corpo.

REFERÊNCIAS

1. Chesney E, Goodwin GM, Fazel S. Risks of all-cause and suicide mortality in mental disorders: a meta-review. *World Psychiatry*. 2014; 13(2):153-60.
2. Murray CJ, Vos T, Lozano R, Naghavi M, Flaxman AD, Michaud C, et al. Disability-adjusted life years (DALYs) for 291 diseases and injuries in 21 regions, 1990-2010: a systematic analysis for the Global Burden of Disease Study 2010. *Lancet*. 2012;380(9859):2197-223.
3. Thornicroft G. Premature death among people with mental illness. *BMJ*. 2013;346:f2969.
4. American Psychiatric Association. Manual diagnóstico e estatístico de transtornos mentais: DSM-5. 5. ed. Porto Alegre: Artmed; 2014.
5. Walker ER, McGee RE, Druss BG. Mortality in mental disorders and global disease burden implications: a systematic review and meta-analysis. *JAMA*. 2015;72(4):334-41.
6. Laursen TM, Nordentoft M, Mortensen PB. Excess early mortality in schizophrenia. *Annu Rev Clin Psychol*. 2014;10:425-48.
7. Crump C, Winkleby MA, Sundquist K, Sundquist J. Comorbidities and mortality in persons with schizophrenia: a Swedish national cohort study. *Am J Psychiatry*. 2013;170(3):324-33.
8. Lawrence D, Hancock KJ, Kisely S. The gap in life expectancy from preventable physical illness in psychiatric patients in Western Australia: retrospective analysis of population based registers. *BMJ*. 2013;346:f2539.
9. Chang C-K, Hayes RD, Perera G, Broadbent MTM, Fernandes AC, Lee WE, et al. Life expectancy at birth for people with serious mental illness and other major disorders from a secondary mental health care case register in London. *PLoS ONE*. 2011;6(5):e19590.
10. Mogadouro MA, Cordeiro Q, Zung S, Vallada H. Mortalidade e esquizofrenia. *Arq Med Hosp Fac Cienc Med Santa Casa São Paulo*. 2009;54(3):119-26.
11. Roshanaei-Moghaddam B, Katon W. Premature mortality from general medical illnesses among persons with bipolar disorder: a review. *Psychiatr Serv*. 2009;60(2):147-56.
12. Lambert TJ, Velakoulis D, Pantelis C. Medical comorbidity in schizophrenia. *Med J Aust*. 2003;178 Suppl:S67-70.
13. Sampaio AMP. Análise dos casos de óbito em pacientes internados em unidade psiquiátrica de hospital geral [dissertação]. Campinas: Universidade Estadual de Campinas; 2007.
14. Byrne P. Organ transplantation and discrimination. *BMJ*. 2000;320(7249):1600.
15. Anil Kumar BN, Mattoo SK. Organ transplant and the psychiatrist: an overview. *Indian J Med Res*. 2015;141(4):408-16.
16. Levenson JL, Oldbrish MF. Psychosocial evaluation of organ transplant candidates. A comparative survey of process, criteria, and outcomes in heart, liver, and kidney transplantation. *Psychosomatics*. 1993;34(4):314-23.
17. Bauchowitz AU, Gonder-Frederick LA, Olbrisch ME, Azarbad L, Ryee MY, Woodson M, et al. Psychosocial evaluation of bariatric surgery candidates: a survey of present practices. *Psychosom Med*. 2005;67(5):825-32.

18. Rosenberger EM, Dew MA, Crone C, DiMartini AF. Psychiatric disorders as risk factors for adverse medical outcomes after solid organ transplantation. *Curr Opin Organ Transplant*. 2012;17(2):188-92.
19. Heinrich TW, Marcangelo M. Psychiatric issues in solid organ transplantation. *Harv Rev Psychiatry*. 2009;17(6):398-406.
20. Shelby SR, Labott S, Stout RA. Bariatric surgery: a viable treatment option for patients with severe mental illness. *Surg Obes Relat Dis*. 2015;11(6):1342-8.
21. Liao CC, Shen WW, Chang CC, Chang H, Chen TL. Surgical adverse outcomes in patients with schizophrenia: a population-based study. *Ann Surg*. 2013;257(3):433-8.
22. Borgio JGF, Barbosa Neto JB, Bressan VR, Daltio CS, Rocha DMLV, Bressan RA. Baixo uso de clozapina em pacientes com esquizofrenia refratária: dados de CAPS e ambulatório universitário. *Anais do 16. Congresso Brasileiro de Psiquiatria*; 2008 Out 15-18; Brasília. Brasília: CBP; 2008.
23. Lopes RD, Banzato CEM, Santos A. Pregnancy delusion hinders the diagnosis of achalasia in a patient with life-threatening emaciation. *Oxf Med Case Reports*. 2014;2014(3):52-4.
24. Saad L, Silva LFAL, Banzato CEM, Dantas CR, Garcia C. Anorexia nervosa and Wernicke-Korsakoff syndrome: a case report. *J Med Case Rep*. 2010;4:217.
25. Druss BG, von Esenwein SA, Compton MT, Rask KJ, Zhao L, Parker RM. A randomized trial of medical care management for community mental health settings: the Primary Care Access, Referral, and Evaluation (PCARE) study. *Am J Psychiatry*. 2010;167(2):151-9.



13

Agitação psicomotora

Antonio Carvalho de Ávila Jacintho

Florindo Stella

João Baptista Laurito Júnior

A agitação psicomotora é um fenômeno comum em qualquer serviço de saúde – urgência/emergência, ambulatorial, internação em hospital geral, etc. Ela pode se apresentar como um enorme desafio, gerando grandes transtornos para todos os profissionais, para os demais pacientes e até para os equipamentos e as instalações, quando o paciente se torna agressivo e violento. Além disso, apesar da relação entre agitação e transtornos mentais, o comportamento agitado pode estar presente em pacientes sem doença psiquiátrica prévia. Este capítulo busca elucidar as principais causas de agitação psicomotora, compreender seus fatores de risco associados, além de oferecer ferramentas para o adequado manejo desse quadro.

CONCEITO E QUADROS CLÍNICOS

Agitação psicomotora e comportamento agressivo fazem parte das condutas humanas, estando presentes em diferentes épocas, sociedades e culturas. Como expressão dos afetos do homem, ela pode ser pensada, inicialmente, como uma conduta de adaptação, ligada intimamente à necessidade de sobrevivência em ambientes hostis. Entretanto, devido a sua complexidade, o significado da agitação e da agressividade vai além da simples questão adaptativa, podendo estar relacionado a outras motivações, como a coação, com vistas à obtenção de algum ganho, à retaliação e também à mera exibição de força e poder.¹

Agitação psicomotora pode ser definida como uma atividade motora excessiva, associada a um sentimento de tensão interna, situando-se como importante capítulo no campo das interconsultas e emergências psiquiátricas no hospital geral. Clinicamente, a agitação psicomotora pode ser caracterizada por sinais de inquietude psíquica e motora facilmente reconhecíveis e também por meio de agressividade verbal e física. Além da alteração da psicomotricidade, o quadro é acompanhado, em geral, por desorganização do psiquismo em graus variados, comprometendo inúmeras vezes a capacidade de crítica do paciente. Sua ocorrência, ou a mera possibilidade de que venha a ocorrer, mobiliza intensamente a equipe de saúde, demandando ações rápidas e eficazes.

Presentes em inúmeros quadros psiquiátricos, os episódios de agitação são frequentemente desorganizados, podendo evoluir para comportamento violento. Além de ser indicador de desorganização mental, tal comportamento pode indicar um quadro psicopatológico subjacente, como esquizofrenia ou outro transtorno psicótico. O estabelecimento de um diagnóstico preciso dependerá de anamnese minuciosa (o que nem sempre é possível) acrescida de exame físico e mental cuidadoso.

A etiologia da agitação psicomotora poderá ser estabelecida a partir do diagnóstico de base, como mostra o Quadro 13.1.

QUADRO 13.1

Principais fatores desencadeantes de agitação psicomotora

Agitação associada a transtornos mentais primários

- Uso de substâncias psicoativas (intoxicação ou abstinência)
- Síndromes maniatiformes
- Quadros paranoides
- Síndromes catatônicas
- Quadros histéricos
- Síndromes fóbico-ansiosas
- Oligofrenia
- Episódio depressivo grave (principalmente em idosos)
- Transtornos da personalidade
 - Antissocial (sociopática)
 - *Borderline* (emocionalmente instável, impulsiva)
- Transtornos mentais na infância
 - Deficiência intelectual
 - Transtorno do espectro autista
 - Transtorno da conduta e transtorno de oposição desafiante

- Transtorno de déficit de atenção/hiperatividade
- Episódio hipomaniaco ou maníaco do transtorno bipolar
- Crianças vítimas de maus-tratos, como abuso sexual infantil
- Crianças usuárias de drogas
- Crianças que tentaram suicídio
- Reação a estresse interpessoal (conflitos no ambiente familiar)

Agitação associada a *delirium* na vigência de condição neuropsiquiátrica específica

- Trauma craniocéfálico (em idosos, hematoma subdural, mesmo leve)
- Agitação em pacientes epiléticos
- Agitação em pacientes com distúrbios do movimento (p. ex., doença de Parkinson, doença de Huntington)
- Agitação associada a doença cerebrovascular (AVC, aneurisma)
- Agitação associada a lesão cerebral expansiva (tumor)

Agitação associada a *delirium* na vigência de doença sistêmica descompensada

- Distúrbios metabólicos (hipoglicemia, hiperglicemia, infecções, hipertireoidismo, uremia, insuficiência hepática)
- Intoxicações (solventes, inseticidas, medicamentos)
- Cardiopatia (infarto agudo do miocárdio, arritmia, angina)
- Pneumopatia (crise asmática, doença pulmonar obstrutiva crônica)

Agitação associada a demência

- Doença de Alzheimer, degeneração lobar frontotemporal (demência frontotemporal, afasia progressiva primária), demência por corpúsculos de Lewy, demência na doença de Parkinson, demência vascular)
- *Delirium* na vigência de um quadro de demência

O PACIENTE AGITADO E A EQUIPE DE SAÚDE

Quadros de agitação psicomotora com frequência precedem o comportamento violento.²

A agitação afeta adversamente a equipe de saúde.³ A agressão de pacientes resulta, para o profissional, em desmoralização, incapacitação física e psicológica, absenteísmo, etc. Além disso, surgem, desse evento, atitudes negativas da equipe em relação ao paciente, gerando um círculo vicioso que promove mais violência.⁴

Pacientes agitados e violentos, depois de o evento ser controlado, passam a ser considerados “difíceis” pela equipe assistencial, o que conduz, na maioria das vezes, à demanda por interconsulta psiquiátrica.⁵ Esses pacientes, como abordado no Capítulo 4, tendem a funcionar psiquicamente com predomínio de mecanismos primitivos de defesa do ego (negação, cisão, onipotência, projeção).

O papel do psiquiatra não se restringe à ação direta sobre o paciente e engloba a compreensão dos mecanismos dinâmicos do funcionamento da equipe assistencial e da própria instituição que abriga o paciente. A presença de atitudes destrutivas do paciente poderá também gerar rejeição e raiva nos membros da equipe.

FATORES DE RISCO PARA COMPORTAMENTO AGITADO E VIOLENTO

A presença de um transtorno mental, por si só, não prediz um comportamento violento. Diversos elementos se associam para determinar tal comportamento, a saber: fatores clínicos (comorbidades e ameaças percebidas), demográficos (idade, sexo, renda), históricos (passado violento, problemas legais na juventude, abuso físico, prisão dos pais) e sociais (divórcio recente, desemprego, história de vitimização). No entanto, no dia a dia de um hospital geral, a agitação psicomotora e a violência relacionam-se estreitamente com transtornos mentais orgânicos ou funcionais.

Na maior parte das vezes, é tarefa difícil prever comportamento agitado e violento, embora existam fatores identificados como preditores, conforme mostram os Quadros 13.2 e 13.3.

QUADRO 13.2

Fatores de risco para agitação psicomotora e comportamento violento

- Ser indivíduo jovem e do sexo masculino.
- Apresentar intoxicação pelo álcool ou outras substâncias psicoativas.
- Apresentar abstinência de álcool ou de outras substâncias psicoativas.
- Apresentar comportamento violento prévio.
- Apresentar quadros psicóticos anteriores.
- Apresentar história prévia de automutilação.
- Apresentar história de condutas delinquentes.
- Pertencer a grupos minoritários.
- Apresentar condições agudas que acometem o sistema nervoso central.

QUADRO 13.3

Preditores de comportamento violento

	Hostil	Agressivo	Violento
Postura	Senta-se na beira da cadeira. Não olha o examinador ou evita seus olhos. Seu tom de voz pode ser elevado ou pode estar lacônico.	Não se senta. Age de forma claramente intimidadora. Faz ameaças verbais, fala - muitos palavrões, fala alto o tempo todo.	Anda de um lado para o outro. Diz que vai agredir alguém presente naquele ambiente. Acabou de agredir alguém.
Psicomotricidade	Inquieto. Tamborila os dedos. Aperta uma mão contra a outra. Morde os lábios.	Quase agitado. Esmurra a parede, gesticula muito. Quebrou objetos em casa.	Agitado. Tem algo nas mãos para se defender ou para agredir alguém. Está quebrando objetos no ambiente.
Humor	Demonstra irritação e falta de empatia com o examinador.	Está raivoso. Demonstra estar com ódio de todos, inclusive do examinador.	Está furioso. Demonstra a decidida intenção de agir violentamente contra alguém.
Risco	Alto	Muito alto	Iminente
Conduta	Uma tentativa de abordagem amigável pode ser bem-sucedida. Tente convencer o paciente a se deixar medicar.	Iniciar o diálogo com muita cautela. Interromper a qualquer sinal de piora. Passar para item VIOLENTO.	As chances de sucesso com o diálogo são remotas. Iniciar imediatamente processo de contenção.

Observação: Mudanças de comportamento são abruptas e inesperadas. Deve-se reavaliar a todo momento.

AVALIAÇÃO DO PACIENTE

Quando um paciente apresenta agitação aguda ou comportamento abertamente agressivo, a primeira atitude deve ser modificar o ambiente para maximizar a segurança de todos os presentes.⁶ As tomadas de decisão devem ser rápidas para se evitar o agravamento do quadro. Dificilmente alguém nessas condições se acalma sozinho, e não se deve esperar por isso, deixando o paciente, a equipe e os demais pacientes do setor em risco.⁷

O paciente agitado chama a atenção – seu semblante é característico, denotando tensão, medo ou mesmo pavor, ódio de alguém, fúria no seu olhar. Fala muito, sem parar, alto ou mesmo gritando, dizendo muitos palavrões. Fala de forma quase monotemática de algo que o perturbou muito recentemente. Pode-se, muitas vezes, perceber, nesse discurso, o grau de desorganização de seu pensamento ou a presença de crenças francamente delirantes (persecutórias, religiosas, místicas). Eventualmente, nota-se o comportamento de alguém perturbado por vozes alucinatórias. Ele anda de um lado para o outro, senta-se e levanta várias vezes, gesticula e, às vezes, esmurra as paredes e/ou os móveis.

A avaliação do paciente agitado e violento inclui anamnese subjetiva (quando isso é possível), anamnese objetiva com familiares, conhecidos ou membros da equipe, exame físico geral, neurológico e psíquico e exames subsidiários (laboratoriais e de imagem cerebral). Deve ocorrer em sala espaçosa onde tanto o examinador quanto o paciente tenham fácil acesso à porta de saída. O examinador deve estar atento para eventual potencial de violência do paciente agitado, e alguns cuidados devem ser tomados (Quadro 13.4).

QUADRO 13.4

Cuidados a serem tomados com o paciente agitado ou violento

- Avaliar o paciente na presença de um membro da equipe de segurança do hospital.
- Não deixar o paciente sozinho ou apenas com familiares.
- Analisar previamente se é prudente estar sozinho com o paciente na sala.
- Manter a porta aberta durante a entrevista, de modo a facilitar a saída do médico ou do paciente.
- Identificar-se claramente, de forma cordial e respeitosa, dizendo nome e profissão, de modo a tranquilizar o paciente de que se trata de um profissional da saúde disposto a ajudá-lo.
- Evitar confronto ou ameaça em relação ao paciente.
- Evitar contato físico, pois o paciente poderá interpretá-lo como ameaça ou assédio sexual, de acordo com seu estado psíquico.
- Conter fisicamente o paciente, quando necessário.
- Pesquisar consumo de álcool ou drogas.
- Prescrever medicação adequada.

Três grupos principais de fatores determinantes do quadro de agitação psicomotora ou heteroagressividade devem ser pesquisados:

- Fatores etiológicos devidos a uma condição fisiopatológica
 - Nessa condição, em geral, o paciente inicia o quadro de forma súbita, apresentando alterações repentinas do estado de humor (irritabilidade, heteroagressividade, às vezes, elementos sugestivos de apatia). Outros indicadores são confusão mental com rebaixamento do nível de consciência e sintomas compatíveis com comprometimento

cognitivo, principalmente desorientação em relação a tempo e espaço e problemas de memória. Trauma craniencefálico, epilepsia, intoxicação por substâncias exógenas, medicamentos com ação psicoativa, distúrbios metabólicos ou enfermidade crônica descompensada e síndromes de abstinência constituem os principais fatores etiológicos dos sintomas mencionados.

- Sintomas psicóticos agudos
 - Episódios psicóticos em pacientes com transtorno bipolar, esquizofrenia ou outros transtornos delirantes crônicos costumam estar associados a quadros de agitação psicomotora.
- Transtornos da personalidade
 - Podem ocorrer episódios de reações agudas a situações que exijam novas formas de ajustamento a situações de estresse ou que geram sofrimento emocional, como conflitos familiares e conjugais, separações, luto, etc. Os quadros agudos são mais frequentes em pacientes com personalidade do tipo *borderline* e personalidade histriônica e em pacientes com traços de impulsividade e de comportamento agressivo.

TRATAMENTO

Pacientes agitados ou violentos podem necessitar de internação involuntária, seja para sua própria proteção, seja para a proteção da família e da comunidade. Caso a decisão do médico e da família seja pela não hospitalização, tanto os familiares quanto outras pessoas próximas devem ser alertados quanto aos riscos que um paciente agitado ou violento pode oferecer.

Manejo verbal

O manejo verbal da agressividade, apesar dos riscos envolvidos, deve ser uma alternativa nos casos indicados no Quadro 13.3. Se possível, a abordagem deve ser feita por um profissional que já conheça o paciente, mas sempre pelo profissional mais experiente da equipe. O profissional deve se identificar claramente, dizer qual sua função e que está disposto a ajudar o paciente em sua aflição ou preocupação.

O profissional deve agir de forma a tranquilizar o paciente, respeitando seu espaço físico (evitar excesso de proximidade ou tocar o paciente), escutando atentamente, nunca desafiando ou duvidando do que ele fala. Ele deve buscar uma forma de concordar com o paciente, mesmo que tenha de usar fórmulas genéricas do tipo “outra pessoa estaria nervosa como você nessa situação”.

Se for preciso estabelecer algum limite, do tipo “o senhor não pode agredir as pessoas aqui do hospital”, deve-se fazê-lo de forma respeitosa e não ameaçadora. Deve-se também dizer que é importante que o paciente se acalme e que o profissional está lá também para isso. Além disso, deve-se reforçar que, uma vez calmo e de “cabeça fria”, ele vai poder tomar decisões sobre o problema. Então, deve-se sugerir que o paciente se deixe medicar para deixá-lo mais calmo.

Contenção física

A contenção física é um procedimento que deve ser determinado como medida protetora do paciente e de outras pessoas e somente deve ser aplicada no contexto do tratamento. A contenção é feita em condições, em geral, adversas, com um paciente que não aceita, não acata e não concorda com o procedimento, e as pessoas ao redor podem não compreender a necessidade dele, ou seja, um cenário contrafeito.

Ademais, é muito importante lembrar que sua indicação e a condição mental do paciente precisam estar claramente reconhecidas, a saber, a iminência de comportamento violento em um paciente mentalmente incapaz (mesmo que temporariamente) quando outras formas de abordagem foram ineficazes ou não foram tentadas por impossibilidade.

A medida mais eficaz para evitar insucesso e proteger o paciente e a equipe no procedimento é o número elevado de pessoas participantes (como ressaltaremos a seguir).

Cuidados quanto à perfusão sanguínea dos membros contidos e aos riscos de lesão, principalmente em idosos, e o controle sistemático dos sinais vitais do paciente são cruciais (Quadro 13.5).

QUADRO 13.5

Procedimentos para restrição física do paciente violento

- Se a restrição física for necessária, determiná-la antes do exame do paciente.
- Verificar, junto aos seguranças, se o paciente não porta armas ou instrumentos que ofereçam risco a si ou aos outros.
- Ao decidir pela restrição física, levar o procedimento até o fim, independentemente dos protestos ou das promessas de bom comportamento do paciente.
- Aproximar-se do paciente acompanhado de um grupo grande de profissionais e auxiliares (6-8 pessoas), com o propósito de deixar claro para ele que seu esforço de evitar a restrição será inútil.
- Durante a restrição, é recomendável que haja um grupo de profissionais especializados nesse tipo de procedimento – um para cada extremidade, outro para tórax e cabeça, e um último que deverá proceder à aplicação das ataduras.
- Certificar-se de que a restrição de cada extremidade não prejudique a perfusão sanguínea ou cause algum tipo de lesão.
- Realizar exame físico e neurológico quando possível. Avaliar sinais vitais. Se possível, efetuar o exame psíquico.
- Não remover as restrições até certificar-se de que não há mais risco de comportamento violento.
- A remoção das ataduras deverá seguir um esquema gradativo: a) tórax; b) um membro inferior; c) o outro membro inferior; d) ambos os membros superiores. Entre uma remoção e outra, deixar um determinado período de tempo para certificar-se de que o paciente não oferece mais riscos.
- Avaliar a presença de intoxicação ou condição clínica que possa ter desencadeado o episódio violento.
- Descrever detalhadamente, no prontuário do paciente, a avaliação médica, os procedimentos adotados e a evolução clínica do paciente.
- Reavaliar periodicamente os sinais vitais e as condições de perfusão dos membros sob restrição.
- Observar possíveis mudanças do estado mental ou da condição clínica geral.

Há crescente preocupação para que se busquem alternativas para a contenção do paciente agitado. No entanto, a falta de protocolos e de estudos que permitam a comparação dos resultados dificulta a criação de alternativas viáveis, distintas das existentes.⁸

Uma vez tomada a decisão pela contenção, inicia-se rapidamente o procedimento. O primeiro passo é conseguir o maior número possível de profissionais disponíveis no local. Não há a necessidade de pessoas especialmente habilitadas para fazer força. O que é decisivo é o número elevado de profissionais. Mesmo pessoas sem treinamento (nunca familiares, acompanhantes nem outros pacientes) podem participar do procedimento para aumentar o número de participantes.

A disponibilidade para agir prontamente é crucial. O treinamento de equipe deve enfatizar principalmente essa prontidão, e a falta de um preparo anterior não deve ser motivo para que alguém não participe do procedimento. Sempre com um profissional à frente da equipe – sempre o mais bem treinado –, o grupo aproxima-se em bloco do paciente e inicia a contenção propriamente dita.

Uma vez iniciada a contenção física, não se pode voltar atrás, mesmo que o paciente prometa se acalmar. Alerta-se que não se faz contenção pela metade. Após realizada a primeira contenção, é importante reavaliar, tantas vezes quanto necessário, a imobilização das extremidades e do tórax. Isso deve focalizar tanto a adequação dessa imobilização (para que o paciente não possa se soltar) quanto a devida perfusão nas extremidades ou alguma posição de risco ou incômoda demais para ele. Nunca é demais lembrar que, feita a contenção, se medica o paciente para acelerar o processo de controle da situação. Não se justifica um paciente estar contido sem estar medicado.

Um homem de 35 anos é trazido por policiais, nu, com informação de que assim estava correndo nas ruas. Quando foi abordado, mostrou-se extremamente hostil, tendo sido necessários vários policiais para o colocarem na viatura. No momento da aproximação da equipe de psiquiatria do pronto-socorro, o paciente voltou a dizer impropérios e fez ameaças, dizendo “ninguém vai pôr a mão em mim senão vai levar p...”, e encontrava-se ainda algemado.

Imediatamente, foi acionada a equipe de contenção, que compareceu com seis profissionais de enfermagem (entre enfermeiros e técnicos) de ambos os sexos. Além deles, compunham a equipe o supervisor da psiquiatria, o médico-residente e o interno (aluno do 6º ano de medicina). Quando o grupo se aproximou, o paciente exclamou: “Isso é covardia, assim, nem eu dou conta”. Imediatamente, recuou até a maca que já se achava preparada e, pacificamente, estendeu os braços para se deixar conter e se deitou.

Tratamento farmacológico

Em geral, o tratamento farmacológico para o comportamento agitado ou violento envolve a prescrição de benzodiazepínicos e antipsicóticos de alta potência, isoladamente ou em combinação. Esse procedimento tem por objetivo interromper a agitação psicomotora, diminuir a ansiedade e tranquilizar rapidamente o paciente. O propósito do tratamento não deve ser a sedação do paciente, mas sua tranquilização.

O uso de antipsicóticos de alta potência com baixa atividade cardiovascular, como o haloperidol, ainda é uma importante opção. Aqueles pacientes com agitação psicomotora sem sintomas psicóticos podem se beneficiar de benzodiazepínicos, principalmente os de ação curta, como o midazolam (via oral ou intramuscular), com monitoramento dos níveis de pressão e da função respiratória. Na falta do midazolam injetável (quando for essa a opção), o uso de diazepam, apesar de sua conhecida absorção errática, pode ser uma opção, mesmo intramuscular.

A opção pela medicação via oral (VO) não deve ser desconsiderada, principalmente após a intervenção verbal, pois o paciente se torna mais cooperativo. Além disso, o uso de medicação VO é mais seguro (quanto a efeitos colaterais) e menos traumático para o manejo da situação. O Quadro 13.6 aponta um esquema terapêutico.

QUADRO 13.6

Esquema do tratamento farmacológico de urgência para pacientes com agitação psicomotora ou comportamento violento

Via digestiva

- Haloperidol, 5 mg, VO
Sozinho ou associado a benzodiazepínico
- Diazepam, 10 mg, VO
- Risperidona, 2 mg, VO
Sozinha ou associada a benzodiazepínico
- Olanzapina, 10 mg, VO

Parenteral

- Haloperidol, 5 mg, IM + midazolam, 7,5 ou 15 mg, IM
- Olanzapina, 10 mg, IM

Já está bem documentado na literatura que os antipsicóticos atípicos têm demonstrado ser equivalentes ao haloperidol no tratamento dos quadros de agitação, porém com a vantagem de apresentarem melhor perfil de efeitos colaterais.⁹ No entanto, uma série de obstáculos não permite seu uso mais frequente – além do alto custo, ainda não estão disponíveis todas as apresentações de antipsicóticos atípicos injetáveis no mercado brasileiro.¹⁰

O uso de haloperidol isoladamente foi desencorajado, recentemente, em revisão da Cochrane. No entanto, ainda se mantém como importante opção, desde que em associação com um benzodiazepínico, tanto oral como parenteral (IM). Isso é particularmente útil em situações – muito comum nesses casos – em que não se tem praticamente nenhuma informação sobre o paciente e seu quadro é confuso, não permitindo o estabelecimento de um diagnóstico etiológico. No entanto, é perfeitamente plausível que, assim que se obtiverem dados mais seguros sobre o paciente, este passe a ser tratado com um antipsicótico atípico, adequando-se, então, ao quadro clínico de base.

Os efeitos adversos dos antipsicóticos de primeira geração – sintomas extrapiramidais, ação semelhante à da quinidina no coração, com aumento do intervalo QTc no eletrocardiograma (ECG) e síndrome neuroléptica maligna – são amplamente conhecidos. Tais efeitos devem constar entre os itens com os quais o médico deve se preocupar na constante avaliação do paciente agitado sobre efeitos adversos. No entanto, o uso de medicações anticolinérgicas profilaticamente, para evitar sinais e sintomas extrapiramidais, apesar de recomendado por alguns autores, não parece uma medida justificada em um cenário de emergência, além de não ser consensual.¹¹

CONDIÇÕES ESPECIAIS ASSOCIADAS À AGITAÇÃO PSICOMOTORA

Abstinência de drogas psicotrópicas

De modo geral, os psicofármacos devem ser retirados gradativamente. O aparecimento de sintomas de abstinência de psicofármacos costuma estar relacionado com a interrupção ou a redução rápida de um medicamento em uso prolongado. Várias categorias de medicamentos oferecem risco de abstinência, a saber:

- **Benzodiazepínicos:** entre outros, há sintomas de ansiedade intensa, insônia, irritabilidade, sensação de fadiga, dificuldade de concentração, depressão, sensação de desrealização e despersonalização, distúrbios da sensopercepção, tremores fortes, taquicardia, náuseas e vômitos, dificuldades respiratórias, *delirium* e convulsões.¹²
- **Antidepressivos:** a clomipramina, da classe dos inibidores seletivos da recaptação de serotonina (ISRSs), como a paroxetina, e a venlafaxina, da classe dos inibidores seletivos da recaptação de serotonina e noradrenalina, quando interrompidas de forma abrupta, podem provocar sintomas como taquicardia sinusal, arritmias ventriculares, tremores graves, distúrbios do sono, ansiedade intensa, hiperatividade e agitação psicomotora, entre outros. O tratamento consiste na reintrodução e, posteriormente, na retirada gradativa do antidepressivo. Benzodiazepínicos eventualmente são necessários para aliviar a ansiedade e a agitação psicomotora relacionadas à abstinência.¹³
- **Antiepilépticos:** a retirada abrupta desse tipo de medicação pode deflagrar crises convulsivas e, até mesmo, estado de mal epiléptico, além de confusão mental e sintomas de agitação psicomotora.

Acatisia

A acatisia é um sinal clínico extrapiramidal frequentemente provocado pelo uso de antipsicóticos de alta potência, constituindo uma condição clínica que pode chegar à agitação psicomotora. O paciente apresenta inquietação, com a característica “marcha no lugar” ou necessidade compulsiva de caminhar e/ou se movimentar, em geral, acompanhada de irritabilidade. Tremores grosseiros, mioclonias e inquietação motora também compõem o quadro.

O diagnóstico de acatisia, muitas vezes, é confundido com o quadro de agitação psicomotora típica, sobretudo quando ela é agravada por ansiedade intensa. Em tal circunstância, há o risco de se usarem equivocadamente doses mais elevadas de antipsicóticos, com aumento dos sinais extrapiramidais.

O tratamento da acatisia, em geral, faz-se com a prescrição de benzodiazepínicos, como diazepam, 10 mg, VO. Se o paciente apresentar agitação psicomotora, deverá ser acrescentado haloperidol, 5 mg, IM (1 ampola de 1,0 mL). Recomenda-se fortemente que o paciente seja reavaliado, monitorando-se a evolução do quadro. Se necessário, preconiza-se administrar lorazepam, VO, três vezes ao dia. Entretanto, se o paciente apresentar apenas acatisia, deve-se

reduzir a dosagem do antipsicótico. Betabloqueadores, como o propranolol, de 10 a 40 mg, VO, podem ser úteis. Cabe lembrar que os betabloqueadores são contraindicados para pacientes com asma brônquica, insuficiência respiratória, diabetes insulino-dependente e distúrbios da condução cardíaca. Medicamentos anticolinérgicos, como biperideno, 2 mg, ou benztropina, 2 mg, VO ou IM, também podem ser necessários. Sempre convém atentar para os possíveis efeitos adversos da ação anticolinérgica do biperideno, principalmente o agravamento da condição cognitiva e confusão mental. Outra opção é a amantadina, de 100 a 300 mg, VO – um agonista da dopamina. Obviamente, deve-se pensar em substituir o antipsicótico se os sintomas da acatisia persistirem.

Agitação em gestantes

A paciente grávida merece uma precaução a mais. A literatura não sustenta nenhuma recomendação clara sobre o tratamento da agitação na gravidez.¹⁴ É recomendável, portanto, pesar, com muito cuidado, os riscos do uso de medicações nessa condição. Ver, a esse respeito, o Capítulo 24, sobre uso de psicofármacos durante a gravidez e o puerpério.

Nunca é demais ressaltar que o uso de contenção deve ser evitado ao máximo, e, quando for inevitável, deve-se fazê-lo pelo menor tempo possível, devido ao risco, para a paciente, de obstrução do retorno venoso para o coração, mormente no segundo e terceiro trimestres. Com respeito à medicação, a única informação com evidência na literatura é o uso de haloperidol.¹⁵

Agitação em idosos

Nos idosos, os sintomas de agitação psicomotora podem se iniciar com ansiedade intensa, humor irritável, insônia, heteroagressividade física e verbal, além de comportamentos de recusa de medicação. Nas crises psicóticas, são frequentes delírios e alucinações auditivas e visuais. No *delirium*, ocorre desorientação no tempo e no espaço. Na depressão, humor irritável e ansiedade podem associar-se a inquietação psicomotora.

Não é incomum que idosos internados em hospital geral deixem de receber a medicação psicofarmacológica de uso crônico, evoluindo para abstinência, como mencionado, com ansiedade, agressividade e desorientação, podendo haver taquicardia, hipertensão arterial, sudorese, tremores de extremidades e disfunções respiratórias.^{16,17}

Dados epidemiológicos indicam que 24 a 71% dos episódios de início tardio com características maníacas, em idosos, estão relacionados a comprometimento neurológico.^{18,19} O risco de mortalidade, nesses pacientes, é elevado.

A agitação nos idosos pode ser, ainda, consequência de alguma doença psiquiátrica de base descompensada (esquizofrenia, transtorno bipolar ou transtorno delirante) ou de síndrome de abstinência de álcool ou de outra substância psicoativa.

Delirium constitui uma das principais condições deflagradoras de agitação nos idosos e, em geral, é decorrente de alterações cerebrovasculares do tipo hematoma subdural, doença cerebrovascular, como aneurisma ou acidente vascular cerebral, processo tumoral expansivo,

quadros infecciosos, distúrbios metabólicos, distúrbios hidreletrolíticos, neurotoxicidade por medicamentos, etc.

Outras condições médicas gerais descompensadas também causam agitação, entre elas desidratação e distúrbios metabólicos, particularmente a hipoglicemia. Condições médicas gerais não suficientemente controladas, alterações cardíacas do tipo angina, infarto agudo do miocárdio, arritmias, bem como quadros agudos de pneumopatia com dispneia, também levam ao surgimento de agitação. Neurotoxicidade por interações medicamentosas ou ingesta excessiva de fármacos e a retirada abrupta de determinados medicamentos, como benzodiazepínicos ou alguns antidepressivos, também desencadeiam episódios de agitação. Obstipação intestinal, ou fecaloma, e retenção urinária, ou bixigoma, têm sido consistentemente associadas a episódios de agitação nos idosos.

Tratamento da agitação em idosos

Episódios agudos: estratégias de manejo

1. Orientação da equipe quanto às peculiaridades do funcionamento psíquico e da evolução do estado mental dos idosos é imprescindível.
2. Contenção física, quando necessária, deve ser cuidadosa (riscos de edema, interrupção da perfusão sanguínea, escoriações e fraturas). Devem-se monitorar os sinais vitais.
3. Se medicar, iniciar com doses baixas e elevação gradativa.

Alguns cuidados especiais devem ser adotados no manejo psicofarmacológico dos pacientes idosos agitados (Quadro 13.7).

QUADRO 13.7

Intervenção psicofarmacológica de episódio agudo em pacientes idosos

- Avaliar o perfil de efeitos adversos dos medicamentos, principalmente sedação excessiva, hipotensão e *delirium*.
- Pacientes com demência, com atrofia cerebral proeminente, tendem a ser mais vulneráveis aos efeitos adversos dos antipsicóticos.
- Antipsicóticos requerem observação constante quanto aos efeitos adversos, como sinais extrapiramidais, sonolência, sedação, hipotensão ortostática, distúrbios do ritmo cardíaco e risco de quedas.
- Antipsicóticos de primeira e segunda gerações têm sido associados à elevação de distúrbios metabólicos e de doenças cerebrovasculares, com aumento das taxas de mortalidade. Portanto, seu uso deve ser restrito a períodos curtos, até a remissão do quadro agudo. Após a remissão, deve-se pensar em outras estratégias farmacológicas, como anticolinesterásicos e memantina, para o tratamento de manutenção.
- Clorpromazina e tioridazina, embora com menor potencial de efeitos extrapiramidais do que o haloperidol, apresentam risco elevado de sedação, hipotensão e alterações da funcionalidade cardíaca. Convém evitar a prescrição dessas medicações.
- Medicações de alta potência apresentam menor risco de sedação, porém oferecem risco maior de efeitos extrapiramidais. Deve-se iniciar com doses baixas, observando-se sinais e sintomas extrapiramidais. Haloperidol em gotas é uma opção a ser adotada em ambientes de emergência. Risperidona também está disponível em gotas para o uso nesse contexto. A disponibilidade dessas medicações em gotas favorece o tratamento de pacientes que não aceitam medicação via oral. É necessário retirar a medicação assim que haja controle do episódio de agitação.
- Se necessário o uso de benzodiazepínicos, sugere-se a escolha daqueles com meia-vida curta, observando-se sistematicamente o risco de sedação, hipotensão, rebaixamento do nível de consciência e comprometimento das funções cognitivas. Alprazolam, midazolam, triazolam e lorazepam constituem algumas indicações. Recomenda-se retirar, com cuidado, os benzodiazepínicos após o controle do episódio de agitação.

Agitação como condição crônica na demência

Agitação crônica, caracterizada por inquietação motora constante, maneirismos motores e perambulação diurna ou noturna, é um fenômeno próprio da demência. O tratamento dessa

condição demanda, preferencialmente, intervenção não farmacológica, com base no manejo do ambiente e no controle dos fatores externos que geram esses distúrbios de comportamento.

Quando é necessária a intervenção psicofarmacológica para o controle da agitação leve e moderada, recomenda-se a prescrição de um antidepressivo que não tenha efeitos anticolinérgicos ou risco elevado de sedação ou hipotensão ortostática. Inibidores seletivos da recaptação de serotonina, como trazodona e mirtazapina, representam algumas opções. Obviamente, o monitoramento rigoroso dos efeitos adversos é imprescindível.

Embora os antipsicóticos sejam os psicofármacos mais prescritos para pacientes agitados, seu uso deve ser cauteloso em idosos com demência. Muitos pacientes apresentam melhora do episódio de agitação com o uso de antipsicóticos por períodos breves.²⁰ Os antipsicóticos de primeira e segunda geração utilizados cronicamente têm efeitos adversos importantes, particularmente no metabolismo lipídico e nas taxas de glicemia, com impacto significativo na esfera cerebrovascular e aumento do risco de mortalidade. Por isso, seu uso deve ser restrito, preferencialmente, a episódios de agitação ou agressividade associados a delírios e alucinações, bem como a situações especiais de não resposta a outros tipos de intervenção, e pelo tempo mais breve possível. Deve ocorrer monitoramento regular dos riscos cerebrovasculares (particularmente perfil lipídico e glicemia).^{21, 22}

Com base nos achados de que, na doença de Alzheimer, os episódios de agitação e outros distúrbios neuropsiquiátricos são geralmente decorrentes de déficits colinérgicos, tem sido proposto o uso de anticolinesterásicos (rivastigmina, donepezila e galantamina) e de antilutamatérgicos (memantina).

Pacientes com demência na doença de Parkinson, demência por corpúsculos de Lewy e demência vascular com frequentes episódios de agitação também podem beneficiar-se dessas medicações. Em pacientes com demência frontotemporal, os anticolinesterásicos não demonstraram eficácia comprovada. Nessa condição, o uso de antidepressivos do tipo trazodona ou os ISRSs (citalopram e sertralina) parecem demonstrar benefícios.

O Quadro 13.8 resume o esquema de doses e efeitos adversos dos anticolinesterásicos e do antilutamatérgico memantina.

QUADRO 13.8

Doses e efeitos adversos dos anticolinesterásicos e do antilutamatérgico memantina

Medicação	Dosagem	Efeitos adversos
Rivastigmina	6-12 mg, em duas tomadas (após café da manhã e jantar): iniciar com 1,5 mg e acrescentar mensalmente 1,5 mg até a dosagem total de 12 mg. Selo transdérmico em dose única: iniciar com 5 cm ² (equivalente a 4,5 mg) e elevar mensalmente para 10 cm ² (equivalente a 9,5 mg) e para a dosagem total de 15 cm ² (equivalente a 13,3 mg).	Náusea, vômitos, diarreia, anorexia e perda de peso, insônia, agitação, bradicardia. Menor incidência de efeitos adversos com o selo transdérmico.
Donepezila	5-10 mg, em dose única (após café da manhã): iniciar com 5 mg e, após um mês, elevar a dosagem para 10 mg.	Náusea, vômitos, diarreia, anorexia e perda de peso, insônia, agitação, bradicardia.
Galantamina	16-24 mg, em uma tomada (após café da manhã): iniciar com 8 mg e, após um mês, passar para 16 mg, e, no mês seguinte, 24 mg.	Náusea, vômitos, diarreia, anorexia e perda de peso, insônia, agitação, bradicardia.
Memantina		

10-20 mg, em duas tomadas (após café da manhã e jantar): iniciar com 5 mg e crescer, a cada 10 dias, 5 mg até a dosagem total de 20 mg. Ao atingir a dosagem total, pode-se prescrevê-la para uma tomada única (24 mg) após o café da manhã.

Náusea, vômitos, diarreia, anorexia e perda de peso.

Os efeitos adversos podem ser minimizados com o uso dessas medicações após as refeições – depois do café da manhã e do jantar – e com a elevação lenta das doses. Antidepressivos tricíclicos devem ser evitados. Anticonvulsivantes, como ácido valproico e carbamazepina, oxcarbazepina e lamotrigina também têm sido utilizados, porém, com cuidado, pelo risco de efeitos adversos (sedação excessiva, ganho de peso e discrasia sanguínea, além do risco de interação medicamentosa). Benzodiazepínicos são drogas que, embora contribuam para o controle dos distúrbios da agitação, no idoso elevam substancialmente o risco de rebaixamento do nível de consciência, embotamento cognitivo, sedação e quedas, frequentemente associadas a fraturas, bem como distúrbios paradoxais da psicomotricidade. Por isso, essas substâncias devem ser evitadas. Quando estritamente necessário, convém prescrever-se uma droga de meia-vida curta, com o controle sistemático dos efeitos adversos.

Agitação nos transtornos conversivos

Os transtornos conversivos constituem condição clínica em que um conjunto de sintomas aparentemente neurológicos derivam de situações conflituosas inconscientes ou de situações caracterizadas por intenso estresse. O paciente pode apresentar crises de agitação psicomotora semelhantes a crises epiléticas generalizadas tonico-clônicas. Essas crises têm a função de manter fora da consciência os conflitos intrapsíquicos inconscientes, reduzindo a ansiedade do paciente (ganho primário), ou a de favorecer a obtenção de atenção afetiva (ganho secundário).

Os sintomas motores não obedecem a trajetórias de inervação ou à disposição neuroanatômica da atividade motora. Tradicionalmente, essas crises têm sido denominadas de crises histéricas, pseudocrises ou crises pseudoepiléticas psicogênicas.²³

O diagnóstico diferencial entre crises epiléticas e crises pseudoepiléticas psicogênicas muitas vezes é difícil, uma vez que ambos os fenômenos podem coexistir. Sabe-se que de 33 a 50% dos pacientes epiléticos podem apresentar, também, crises pseudoepiléticas psicogênicas, mais frequentemente em adultos jovens e mulheres.^{24,25}

As características clínicas para o diagnóstico diferencial entre crises epiléticas e crises pseudoepiléticas psicogênicas estão resumidas no Quadro 13.9.

QUADRO 13.9

Diagnóstico diferencial entre crises epiléticas e crises pseudoepiléticas psicogênicas

Crises pseudoepiléticas psicogênicas	Crises epiléticas
■ Início, em geral, gradual, com pródromos variáveis ■ Movimentos bizarros, do tipo “debater-se” ■ Progressão desordenada dos movimentos ■ Preservação da consciência durante a crise ■ Movimentos de caráter intencional ■ Balanço bilateral da cabeça ■ Postura distônica, do tipo opistótono	■ Início, em geral, abrupto, com pródromos semelhantes ■ Movimentos simétricos ■ Movimentos seguem inervação segmentar ■ Perda da consciência durante a crise ■ Movimentos sem autocontrole ■ Movimentos verticais da cabeça ■ Postura tônica ou atônica

- | | |
|---|--|
| <ul style="list-style-type: none"> ■ Fator psicológico desencadeante ■ Não ocorrem durante o sono ■ Duração prolongada: > 20 minutos ■ Resposta a estímulos corneanos ■ Resposta a estímulos dolorosos ■ Mudança de posição quando em desconforto ■ “Quedas” em posição ou locais confortáveis ■ Resistência voluntária à tentativa de contenção física ■ Desvio dos globos oculares em direção ao solo ■ Resistência à tentativa externa de abertura dos olhos ■ Choro, frases, gritos, obscenidades durante ou após a crise ■ “Mordeduras” na ponta da língua e lábios ■ Incontinência urinária praticamente ausente ■ Cianose é evento raro ■ Término gradual da crise ■ Ocorrem diante de outras pessoas ■ Ausência de reflexos anormais no “pós-ictal” ■ “Pós-ictal” não confusional, com riso ou choro ■ Recuperação mnésica detalhada da crise ■ Crise pode ser induzida por sugestão ou solução salina IV (placebo) ■ EEG “ictal” normal ■ Mais frequente no sexo feminino | <ul style="list-style-type: none"> ■ Independentes de fator psicológico desencadeante ■ Podem ocorrer durante o sono ■ Duração curta: 1-4 minutos ■ Ausência de resposta a estímulos corneanos ■ Ausência de resposta a estímulos dolorosos ■ Ausência de mudança voluntária de posição ■ Quedas independentemente de posição ou local ■ Ausência de resistência voluntária à contenção física ■ Posição fixa dos globos oculares ■ Não resistência à tentativa de abertura dos olhos ■ Ausência de comunicação verbal durante a crise ■ Mordedura de língua em suas laterais ■ Incontinência urinária frequente ■ Cianose frequente ■ Término abrupto da crise ■ Ocorrem independentemente da presença de outras pessoas ■ Reflexos extensores abolidos no pós-ictal ■ Pós-ictal confusional, com desorientação ■ Amnésia em relação ao evento ■ Crise desencadeada por ondas cerebrais anormais ■ EEG ictal anormal (pontas-ondas) ■ Ocorrência semelhante em ambos os sexos |
|---|--|

Agitação psicomotora e comportamento agressivo na criança

O psiquiatra deve avaliar se o comportamento agitado ou violento é algo frequente na criança ou se ocorre pela primeira vez, bem como se é indicativo do início de um quadro psicótico ou maníaco diagnosticado previamente. As características do ambiente familiar devem ser averiguadas. Ademais, a possibilidade de a criança ter feito uso de álcool ou outras drogas deve ser descartada, inclusive com a ajuda de recursos laboratoriais.^{26,27}

Algumas crianças e adolescentes apresentam características agressivas mais intensas do que o restante da população da mesma faixa etária. Características do ambiente poderão estimular ou refrear comportamentos agitados ou condutas agressivas. A presença de transtornos psiquiátricos é o fator mais importante relacionado aos fenômenos da agitação motora e da agressividade. Além disso, temperamento individual, modelos parentais (características do ambiente familiar e comportamento agressivo em outros familiares), outras influências ambientais, como escola, comunidade e elementos culturais, poderão estar na base da agitação e da agressividade na infância e na adolescência.^{28,29}

Diversos quadros psiquiátricos na infância e na adolescência, resumidos no Quadro 13.1, podem cursar com agitação motora ou comportamento agressivo e violento. O Quadro 13.10 resume orientações de manejo.

QUADRO 13.10

Avaliação e manejo da agitação motora e do comportamento agressivo na criança

- Avaliar a situação de agitação motora ou violência e garantir a proteção da criança, de sua família e da equipe médica.
- Avaliar o potencial de a criança ou o adolescente se ferir ou ferir outras pessoas.
- Optar por condutas não ameaçadoras.
- A contenção física ou medicamentosa pode ser a primeira escolha em casos em que a segurança esteja ameaçada, mesmo que ainda não tenha sido estabelecido um diagnóstico etiológico preciso.
- O local da avaliação deve ser tranquilo, bem iluminado e oferecer segurança a todos, inclusive com possibilidade de escape fácil em situações extremas.

- A presença de membros da equipe de segurança da unidade de emergência pediátrica pode ser necessária.
- O médico deve decidir a conveniência ou não da presença de familiares dentro da sala onde a criança está sendo avaliada.
- Evitar contenção mecânica ou medicamentosa em crianças pequenas. Optar pela contenção em casos extremos.
- Em crianças, medicamentos psicotrópicos apresentam risco aumentado para efeitos colaterais e reação paradoxal.
- Avaliar se é o primeiro episódio ou se já ocorreram quadros semelhantes previamente.
- Descrever detalhadamente o quadro atual e os quadros anteriores, se houver.
- Investigar fatores de piora e melhora no(s) episódio(s) prévio(s).
- Pesquisar as condutas eficazes no(s) episódio(s) anterior(es).
- A resposta efetiva a um determinado psicofármaco utilizado no episódio anterior, assim como efeitos colaterais e reação paradoxal, são dados que deverão ser pesquisados e levados em conta na escolha do medicamento para o episódio atual.
- Pesquisar agitação motora e comportamento agressivo em outros membros da família, bem como o uso de medicamentos psicofármacos no episódio ocorrido com o familiar.
- Investigar antecedentes pessoais e familiares para transtornos psiquiátricos.
- Descartar consumo de álcool e drogas, realizando, inclusive, exames laboratoriais (*doping*).
- Investigar ingestão acidental ou intencional de medicamento psiquiátrico.
- Avaliar a necessidade de internação hospitalar.
- Uma intervenção legal (Conselho Tutelar, Juizado da Infância, Polícia) pode ser necessária, especialmente em adolescentes com transtorno da conduta grave e comportamento delinquente.

Após a avaliação clínica, deve ser definida a necessidade ou não de contenção física ou química, por meio do uso de psicofármacos. Uma abordagem não ameaçadora, sem utilização de contenção ou medicamentos, é sempre mais adequada. Entretanto, algumas crianças com quadros mais graves necessitarão de contenção, muitas vezes antes mesmo do estabelecimento de um diagnóstico etiológico preciso.^{30,31}

A sedação plena já foi considerada o objetivo principal no manejo de pacientes agitados, mas, atualmente, a sedação excessiva é vista como efeito indesejável, porque interfere na avaliação da criança. O objetivo do uso de fármacos sedativos é tranquilizar o paciente o mais rápido possível, reduzindo o risco de auto e heteroagressão, além de permitir a investigação diagnóstica e a abordagem terapêutica.

Portanto, o uso de psicofármacos deve ser reservado para casos mais graves, pelo risco aumentado de efeitos colaterais, toxicidade medicamentosa e reação paradoxal.^{31,32} As drogas psicotrópicas são eliminadas mais rapidamente pelas crianças do que pelos adultos. Isso se deve à maior capacidade de metabolização hepática, à maior filtração glomerular e à menor quantidade de tecido adiposo presente nas crianças quando comparadas com os adultos. Assim, crianças podem necessitar ou tolerar dosagens maiores do que adultos, em termos de miligramas por quilograma de peso.^{32,33}

Em relação ao uso de psicofármacos, as seguintes regras básicas deverão ser respeitadas:

1. Agentes antipsicóticos são os psicofármacos de primeira escolha no controle da agitação e do comportamento agressivo em crianças.
2. Haloperidol é o psicofármaco mais usado na infância, com perfil de segurança bem estabelecido por vários estudos. As doses devem variar entre 0,1 e 0,5 mg/kg/dia, com dose máxima de 1 mg/kg/dia. É importante lembrar o risco para distonia aguda e discinesia.
3. Risperidona está indicada na seguinte dosagem: em crianças com menos de 45 kg, 0,02 mg/kg peso/dia; em crianças com mais de 45 kg, 0,5 a 1 mg/dia (dose máxima deve chegar a 2 mg/dia, dividida em 2 a 4 tomadas).
4. Benzodiazepínicos poderão ser usados, mas com cautela. Crianças são mais sensíveis aos efeitos colaterais do diazepam (metabolização mais lenta – 2 a 5 vezes), e é comum a ocorrência de excitação paradoxal, especialmente em crianças com transtorno de déficit de

atenção/hiperatividade (TDAH). O midazolam injetável é uma opção (doses variando entre 0,15 e 0,20 mg/kg/dia), mas pode produzir amnésia retrógrada.

5. Antipsicóticos fenotiazínicos, como a clorpromazina, poderão ser usados, com boa capacidade de sedação, em doses variando entre 3 e 6 mg/kg/dia. Contudo, em função de possíveis alterações cognitivas causadas pelos efeitos anticolinérgicos, devem ser usados com cautela em crianças.
6. A prometazina, uma medicação fenotiazínica sem propriedades antipsicóticas, mas com boa capacidade de sedação, pode ser uma opção para administração VO ou IM, em doses variando entre 0,5 e 1 mg/kg/dia. Pode ser usada isoladamente ou em associação com clorpromazina ou haloperidol. Existe, no entanto, risco aumentado em crianças para reação de excitação paradoxal.
7. Eletroconvulsoterapia pode ser usada em casos graves de agitação, refratários ao tratamento com psicofármacos.
8. Para o tratamento de manutenção, o uso de lítio poderá ser indicado após a alta da unidade de emergência, buscando-se uma dosagem que mantenha níveis séricos entre 0,4 e 1,2 mEq/L. As funções renal e tireoidiana devem ser monitoradas. Outra escolha, nesses casos, poderá ser a carbamazepina, iniciando-se com dosagem entre 10 mg/kg/dia até 20 a 30 mg/kg/dia.

Muitas famílias relutam em procurar uma consulta psiquiátrica para uma criança com problema de agitação ou condutas agressivas. Assim, a sala de emergência acaba sendo o único modo de engajamento em um serviço de psiquiatria para um enorme número de crianças com graves perturbações psíquicas. Na maioria das vezes, a família também deverá ser encaminhada para acompanhamento.³⁴

ASPECTOS ÉTICOS E LEGAIS DO MANEJO COM PACIENTES AGITADOS

Aspectos éticos e legais relacionados à contenção física são abordados no Capítulo 28.

Aqui, sinteticamente, lembramos que o maior dilema no processo de avaliação do paciente (que está em vias de ou já cometeu um ato violento) é caracterizar sua perda da capacidade mental naquele momento. A justificativa para impor uma medida coercitiva (medicação, contenção, retenção do paciente internado) é ele ser incapaz mentalmente de julgar seus atos e se determinar por esse julgamento.

Um indivíduo temporariamente perturbado por uma intoxicação por álcool pode ser submetido involuntariamente a tratamento. Esse mesmo indivíduo, 8 a 12 horas depois, quando o álcool já tiver sido metabolizado, não poderá mais ser submetido ao mesmo tipo de tratamento. Um paciente que se torna agressivo no setor do hospital porque se recusa a receber um determinado tratamento que não tem nenhum transtorno psiquiátrico ou sinal de intoxicação não poderá ser submetido a nenhuma forma de tratamento involuntário.³⁵

REFERÊNCIAS

1. Onyke CH, Lyketsos CG. Aggression and violence. In: Levenson J, editor. The American Psychiatric publishing textbook of psychosomatic medicine psychiatric care of the medically III . 2nd ed. Geneva: APA; 2011. p. 153-74.
2. Sachs GS. A review of agitation in mental illness: burden of illness and underlying pathology. J Clin Psychiatry. 2006;67(Suppl 10):5-12.
3. Mintzer JE. The clinical impact of agitation in various psychiatric disorders: management consensus and controversies. J Clin Psychiatry. 2006;67(Suppl 10):3-4.
4. Downey LVA, Zun LS, Gonzales SJ. Frequency of alternative to restraints and seclusion and uses of agitation reduction techniques in the emergency department. Gen Hosp Psychiatry. 2007;29(6):470-4.
5. Groves JE. Difficult patients. In: Stern TA, Fricchione GL, Cassem NH, Jellinek MS, Rosenbaum JF. Handbook of general hospital psychiatry. Philadelphia: Mosby; 2004. p. 293-312.
6. Richmond SJ, Berlin JS, Fishkind AB, Holloman BH, Zeller SL, Wilson MP, et al. Verbal de-escalation of the agitated patient: Consensus Statement of the American Association for Emergency Psychiatry Project BETA de-escalation workgroup. West J Emerg Med. 2012;13(1):17-25.
7. Garriga M, Pacchiarotti I, Kasper S, Zeller SL, Allen MH, Vázquez G, et al. Assessment and management of agitation in psychiatry: expert consensus. World J Biol Psychiatry. 2016;17(2):86-128.
8. Migon MN, Coutinho ES, Huf G, Adams CE, Cunha GM, Allen MH. Factors associated with the use of physical restraints for agitated patients in psychiatric emergency rooms. Gen Hosp Psychiatry. 2008;30(3):263-8.
9. Caine ED. Clinical perspectives on atypical antipsychotics for treatment of agitation. J Clin Psychiatry 2006;6(Suppl 10):22-31.
10. Lukens TW, Wolf SJ, Edlow JA, Shahabuddin S, Allen MH, Currier GW, et al. Clinical policy: critical issues in the diagnosis and management of the adult psychiatric patient in the emergency department. Ann Emerg Med. 2006;47(1):79-99.
11. Bazire S. Psychotropic drug directory. London: Fivepin; 2016.
12. Stahl SM. Psicofarmacologia: bases neurocientíficas e aplicações práticas. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan; 2014.
13. Schatzberg AF, Cole JO, DeBattista C. Manual de psicofarmacologia clínica. 6. ed. Porto Alegre: Artmed; 2009.
14. Ladavac AS, Dubin WR, Ning A, Stuckeman PA. Emergency management of agitation in pregnancy. Gen Hosp Psychiatry. 2007;29(1):39-41.
15. Diav-Citrin O, Shechtman S, Ornoy S, Arnon J, Schaefer C, Garbis H, et al. Safety of haloperidol and penfluridol in pregnancy: a multicenter, prospective, controlled study. J Clin Psychiatry. 2005;66(3):317-22.

- Cummings I, Mendez ML. Secondary mania with focal cerebrovascular lesions. *Am J Psychiatry*. 1984;141(9):1084-7.
16. Gutiérrez JLA. Trastorno bipolar en el anciano. *Psiquiatr Biol*. 1998;19(3):161-5.
18. Shulman KI, Tohen M, Satlin A, Mallya G, Kalunian D. Mania compared with unipolar depression in old age. *Am J Psychiatry*. 1992;149(3):341-5.
19. Stone K. Mania in the elderly. *Br J Psychiatry*. 1989;155:220-4.
20. Gauthier S, Cummings J, Ballard C, Brodaty H, Grossberg G, Robert P, et al. Management of behavioral problems in Alzheimer's disease. *Int Psychogeriatr*. 2010;22(3):346-72.
21. Ballard C, Lana MM, Theodoulou M, Douglas S, McShane R, Jacoby R, et al. Investigators DART AD: a randomized, blinded, placebo-controlled trial in dementia patients continuing or stopping neuroleptics (the DART-AD trial). *PLoS Med*. 2008;5(4):e76.
22. Gauthier S, Loft H, Cummings J. Improvement in behavioral symptoms in patients with moderate to severe Alzheimer's disease by memantine: a pooled data analysis. *Int J Geriatr Psychiatry*. 2008;23(5):537-45.
23. Marchetti RL. Aspectos psiquiátricos da epilepsia. In: Costa JC, Palmini A, Yacubian EMT, Cavaleiro EA, editores. *Fundamentos neurobiológicos das epilepsias: aspectos clínicos e cirúrgicos*. São Paulo: Lemos; 1998.
24. Ramsay RE, Colen A, Brown MC. Coexisting epilepsy and non-epileptic seizures. In: Rowan AJ, Gates JR, editors. *Non-epileptic seizures*. Boston: Butterworth-Heinemann; 1993.
25. Kurcgant WA, Marchetti RL, Marques AH, Marcetti LB. Crises pseudoepilépticas: diagnóstico diferencial. *BJECN*. 2000;6:13-8.
26. Buchmann A, Hohmann S, Brandeis D, Banaschewski T, Poustka L. Aggression in children and adolescents. *Curr Top Behav Neurosci*. 2014;17:421-42.
27. Deshmukh P, Kulkarni G, Barzman D. Recommendations for pharmacological management of inpatient aggression in children and adolescents. *Psychiatry (Edmont)*. 2010;7(2):32-40.
28. Pisano S, Mucci M, Mais G. Psychiatric emergency department for youth: a challenge for the future of child and adolescent mental health. *Int J Emerg Ment Health*. 2016;18(2):742.
29. Stahl S. *Stahl's essential psychopharmacology: neuroscientific basis and practical applications*. 4th ed. Cambridge: Cambridge University; 2013.
30. Barzman DH, Findling RL. Pharmacological treatment of pathologic aggression in children. *Int Rev Psychiatry*. 2008;20(2):151-7.
31. Scahill L, Oosterheld JR, Martin A. General principles, specific drugs treatment, and clinical practice. In: Martin A, Volkmar FR, Lewis M, editors. *Child and adolescent psychiatry: a comprehensive textbook*. Philadelphia: Lippincott Williams & Wilkins; 2007. p. 754-88.
32. Rauch P, Jellinek M. Paediatric consultation. In: Rutter M, Taylor E. *Child and adolescent psychiatry*. 4th ed. New York: Blackwell; 2004. p. 529-54.
33. Oosterheld JR, Shader RI, Martin A. Clinical and developmental aspects of pharmacokinetics and drug interaction. In: Martin A, Volkmar FR, Lewis M, editors. *Child*

and adolescent psychiatry: a comprehensive textbook. Philadelphia: Lippincott Williams & Wilkins; 2007. p. 742-53.

34. Jaacap.com [Internet]. Practice Parameters. JAACAP; c2016 [capturado em 23 dez. 2016]. Disponível em: <http://www.jaacap.com/content/pracparam>.
35. Abdalla-Filho E, Chalub M, Telles LEB. Psiquiatria forense de Taborda. 3. ed. Porto Alegre: Artmed; 2016.



Delirium (estado confusional agudo)

Luiz Fernando de Almeida Lima e Silva
Amilton dos Santos Júnior

Delirium é uma complicação frequente de pacientes internados no hospital geral, em especial aqueles com condições clínicas graves. É uma síndrome que, apesar de indicar uma condição subjacente grave, é frequentemente subdiagnosticada e indicativa de mau prognóstico, estando associada a maiores taxas de morbimortalidade. Além disso, seu desenvolvimento relaciona-se a internações mais longas e a aumento nos custos hospitalares. A confusão mental e a agitação psicomotora que esses pacientes comumente desenvolvem tornam o manejo dos casos um desafio para médicos, enfermeiros e demais profissionais da equipe. Este capítulo aborda os elementos centrais na identificação, na investigação clínica, no diagnóstico diferencial e no tratamento de pacientes com *delirium*.

Delirium, ou estado confusional agudo, é um transtorno neuropsiquiátrico agudo caracterizado por estreitamento da consciência, prejuízo na atenção e alterações cognitivas e sensoperceptivas. Geralmente, existem evidências na história de vida, no exame físico ou nos exames laboratoriais de que o transtorno é uma consequência fisiológica direta de uma condição médica geral, intoxicação ou abstinência de substâncias psicoativas, uso de medicação, exposição a toxinas ou uma combinação desses fatores.^{1,2} Por haver ampla variedade de etiologias subjacentes, cuja identificação é parte do tratamento clínico, o *delirium* é considerado uma síndrome, e não um transtorno unitário.

Na literatura médica, são encontrados diversos sinônimos para *delirium*, o que transmite a falsa ideia de que cada uma de suas causas caracterizaria um transtorno próprio, e não uma síndrome, com elementos comuns a todas elas (Quadro 14.1). Apesar da grande variação na apresentação do quadro, suas características centrais são evidenciadas na maioria dos casos.³

QUADRO 14.1

Termos usados para designar *delirium*

- Demência aguda
- Demência reversível
- Encefalopatia metabólica
- Encefalopatia tóxica
- Estado confusional
- Psicose exógena
- Síndrome cerebral orgânica
- Psicose da UTI

Fonte: Com base em Trzepacz e colaboradores.³

O quadro clínico de *delirium* pode mimetizar uma série de transtornos mentais, como depressão, esquizofrenia e mania. Além disso, o caráter flutuante dos sintomas, com períodos de melhora e de piora, é outro obstáculo que torna o diagnóstico um desafio. O conhecimento de suas características e a vigilância para seu diagnóstico são imperativos, tanto ao psiquiatra

interconsultor quanto ao médico generalista, tendo em vista sua alta incidência e prevalência em pacientes internados em hospital geral e sua importância clínica (indicando patologia clínica subjacente) e prognóstica (está associado a internações mais longas e é indicativo de mau prognóstico).

EPIDEMIOLOGIA

Os valores de prevalência e incidência de *delirium* variam de acordo com as características da população estudada. Ainda assim, é a síndrome psiquiátrica mais comumente encontrada no contexto hospitalar.⁴

O *delirium* afeta 10 a 45% dos pacientes internados, principalmente aqueles com idade avançada,⁵ que sofrem de doenças graves, como câncer,⁶ e/ou que são submetidos a procedimentos cirúrgicos.⁷ Em pacientes terminais, a prevalência chega a 85%.⁸ Apesar de idosos serem mais propensos a apresentar quadros confusionais agudos, essa complicação também pode acontecer em adultos jovens ou mesmo em crianças.⁹

Pacientes vítimas de trauma também apresentam risco aumentado de desenvolver *delirium*, com incidência em politraumatizados que necessitaram de ventilação mecânica chegando a 67%.¹⁰ Entre os internados em unidades de terapia intensiva (UTI), 59% desenvolveram *delirium*.¹¹ No subgrupo que necessitou de ventilação mecânica (36%), a incidência foi de 92%.

Santos e colaboradores,¹² em um estudo com pacientes idosos submetidos a cirurgia ortopédica para correção de fratura de quadril, relataram incidência de *delirium* de 55,9%. Segundo Kalisvaart e colaboradores,¹³ pacientes submetidos a cirurgia no quadril desenvolveram quatro vezes mais *delirium* nos casos em que foram necessárias cirurgias de urgência em comparação a eletivas (29,6 contra 7,3%).

Nos pacientes que sofreram infarto agudo do miocárdio, Uguz e colaboradores¹⁴ reportaram incidência de *delirium* de 5,7%, com consequente prolongamento da internação e aumento da mortalidade. McManus e colaboradores,¹⁵ em uma revisão, relataram incidência de *delirium* na fase aguda de casos de acidente vascular cerebral (AVC) entre 13 e 48%.

FATORES PREDISPONTES E PRECIPITANTES

Indivíduos com idade avançada, lesão cerebral prévia e comprometimento cognitivo são particularmente vulneráveis ao desenvolvimento de *delirium*.¹⁶ O risco é nove vezes maior em pacientes com comprometimento cognitivo preexistente.¹⁷ A prevalência em pacientes com demência também é significativamente superior.

Wahlund e Björclin¹⁸ relataram que 67% dos pacientes com *delirium* apresentavam doença infecciosa como principal fator associado ao seu desenvolvimento. Doença terminal também é um fator de risco importante, com incidência de até 88%.¹⁹

O *delirium* é frequentemente iatrogênico, resultando de problemas como efeitos colaterais de medicações, estresse secundário a cirurgia, complicações de procedimentos ou imobilização. Durante a hospitalização, ocorre uma confluência de fatores de risco para *delirium*, o que torna essa condição relativamente comum em pacientes internados. Estima-se que 44% dos idosos internados que apresentam *delirium* tenham mais de uma única etiologia identificada, com uma média de 2,8 por indivíduo.²⁰ O risco cresce com o aumento de fatores predisponentes. O Quadro 14.2 resume as principais condições habitualmente relacionadas ao desenvolvimento de *delirium*.

QUADRO 14.2

Condições geralmente associadas a *delirium*

Doenças sistêmicas ou infecciosas

- Pneumonia
- Infecção urinária
- Seps
- Embolia pulmonar
- Choque
- Pós-operatório
- Doenças cardiovasculares (infarto agudo do miocárdio, insuficiência cardíaca congestiva, endocardite)
- Trauma grave
- Controle inadequado da dor

Distúrbios tóxico-metabólicos

- Distúrbios hídreletrolíticos (como desidratação e distúrbios de sódio e potássio)
- Distúrbios acidobásicos
- Hiper ou hipoglicemia
- Insuficiência renal ou uremia
- Insuficiência hepática
- Endocrinopatias (como hiper ou hipotireoidismo)
- Carências nutricionais (como deficiência de tiamina)

Doenças do sistema nervoso central

- Acidente vascular cerebral
- Doenças degenerativas
- Encefalopatia hipertensiva
- Convulsão ou estado pós-ictal
- Traumatismo craniano/hematoma subdural
- Encefalite ou meningite
- Tumor cerebral

Abuso ou abstinência de álcool e outras substâncias psicoativas

Medicações e fármacos (em especial polifarmácia)

- Agentes anticolinérgicos
- Benzodiazepínicos ou hipnóticos
- Diuréticos
- Digitálicos

- Drogas anti-hipertensivas
- Antiarrítmicos
- Serotonérgicos
- Lítio
- L-Dopa
- Anti-inflamatórios
- Narcóticos ou opioides
- Quimioterapia

Fonte: Maldonado,⁴ Almeida²¹ e American Psychiatric Association.²²

FISIOPATOLOGIA

O quadro de *delirium* é classicamente considerado uma síndrome decorrente de disfunção generalizada de funções corticais superiores, com ampla gama de sintomas neuropsiquiátricos associados a lentificação difusa no ritmo dominante posterior do eletrencefalograma. Pesquisas têm demonstrado que o comprometimento de regiões específicas do cérebro, como córtex pré-frontal, córtex parietal posterior direito superficial, região talâmica anterior direita, gânglios da base, córtex fusiforme (ventromedial temporoparietal) e giro lingual, desempenha um papel central na determinação da fisiopatologia do quadro, constituindo uma *via final comum*, mesmo considerando suas várias etiologias possíveis.^{3,23}

A principal teoria em vigência propõe que a fisiopatologia dos quadros de *delirium* está associada a um desequilíbrio entre as vias colinérgicas e dopaminérgicas. Essa hipótese é consistente para explicar os sintomas e as vias neuroanatômicas possivelmente implicadas.²⁴

R., 76 anos, foi trazida à Unidade de Emergência Referenciada da Unicamp por alteração do comportamento, com início há cinco dias. Apresenta-se agitada, inquieta, não dorme, fala sozinha e com discurso desconexo. O acompanhante afirma que, em alguns momentos, ela parece mais “calma e lúcida”, alternando-se com outros de comportamento desorganizado e discurso incoerente, principalmente à noite. A família está assustada, com medo de que ela saia de casa sozinha. Durante a madrugada, a paciente fala que “vai ao mercado” ou relembra elementos de seu passado, associando as ideias de maneira frouxa. Antes da instalação do quadro, a paciente não tinha comprometimento grave da memória. Apresenta hipertensão arterial e diabetes tipo 2.

Na avaliação, a paciente não colabora com o exame físico. Está confusa, perplexa e se assusta com sons do ambiente. Distrai-se com facilidade, não foca a atenção nas perguntas. Quando as responde, revela-se desorientada no tempo e no espaço, com ideias desconexas.

DIAGNÓSTICO E AVALIAÇÃO

Sinais e sintomas

Delirium é o termo usado para designar um transtorno agudo da função cognitiva global. Os sinais e sintomas incluem uma combinação de elementos cognitivos, comportamentais e psicopatológicos. De acordo com as classificações atuais,^{1,2} o aspecto central para o diagnóstico de *delirium* é uma perturbação da consciência, com redução da capacidade de direcionar, focalizar, manter ou deslocar a atenção. O quadro é acompanhado por prejuízo cognitivo (distúrbios da memória, orientação e linguagem) não atribuível a quadro de demência instalado ou em desenvolvimento.

A avaliação direta do estado de consciência nem sempre é fácil, embora a identificação de seus polos extremos (vigília e coma) seja relativamente simples. O aspecto característico de *comprometimento da consciência* (*consciousness clouding*) é pobremente definido e, muitas vezes, de difícil reconhecimento, sendo, com frequência, medido de forma indireta por meio da *avaliação da atenção* (incapacidade de controlá-la e de manter seu foco). Distúrbio da atenção é o sintoma cardinal de *delirium* e, para muitos autores, o elemento central da síndrome, o que é enfatizado no *Manual diagnóstico e estatístico de transtornos mentais* (DSM-5) em detrimento do uso do conceito de “consciência”,^{1,25} trazendo implicações significativas para a consolidação do diagnóstico formal desses pacientes, o que será abordado mais adiante.

Com o comprometimento da cognição, o pensamento pode ser confuso, com afrouxamento associativo e tangencialidade. Desorientação temporal é mais comum. Em casos graves, pode haver também desorientação espacial e pessoal. A capacidade de racionalizar e de emitir julgamentos costuma estar comprometida e contribui para o desenvolvimento de ideias delirantes em aproximadamente 20% dos idosos com *delirium*.²⁶ Na maioria dos casos, as ideias são mal estruturadas e transitórias.

Alterações da sensopercepção também podem ocorrer. Ilusões patológicas (distorções de estímulos sensoriais reais e que não são passíveis de correção) e alucinações (principalmente visuais) são frequentes e podem ser observadas em 20 a 30% dos casos.²⁶ Cutting²⁷ demonstrou que os distúrbios perceptivos em pacientes com quadros psicóticos orgânicos agudos foram mais visuais do que auditivos.

Os sintomas psicóticos e a alteração do comportamento podem ser tão proeminentes que dificultam a avaliação clínica, o diagnóstico e a identificação etiológica, com consequente aumento do risco de óbito. Não está claro se os sintomas psicóticos decorrem de causas específicas, de distúrbios cognitivos com comprometimento da compreensão ambiental, de alterações perceptivas, como parte de flutuações do humor ou, ainda, de alguma vulnerabilidade individual.²⁰

Instabilidade emocional, ansiedade, agitação, depressão/irritabilidade são observadas em até 60% dos pacientes.²⁶ Pode haver apatia, perplexidade e até quadros maniatiformes. Esses sintomas requerem tratamento específico quando acompanhados de agitação psicomotora e comportamento agressivo.

Como é necessário que a atenção esteja preservada para a aquisição de novos conteúdos, o comprometimento da memória recente pode tanto representar um déficit mnêmico real quanto ser secundário a prejuízo atencional. A memória remota costuma estar preservada.²⁸

Indivíduos em *delirium* também costumam manifestar alterações motoras, desde inquietação/agitação até letargia/apatia. Podem, ainda, oscilar entre esses polos, manifestando quadro misto. Inversão do ciclo sono-vigília, insônia, sonolência diurna e pesadelos vívidos não são raros, com típica piora dos sintomas ao anoitecer, fenômeno conhecido como *sundowning*.

A flutuação da intensidade dos sintomas no período de 24 horas dificulta o diagnóstico. Essa característica comumente leva a equipe de enfermagem e/ou os familiares em contato mais próximo com o paciente a perceber os períodos de confusão mental. Logo, o médico assistente deve valorizar informações obtidas com acompanhantes, cuidadores e demais membros da equipe.

Apesar do grande espectro sintomático, é possível destacar alguns sintomas nucleares que costumam ocorrer independentemente da etiologia. Outros sinais e sintomas acessórios podem se manifestar, relacionando-se possivelmente a etiologias específicas (Quadro 14.3).^{23,28}

QUADRO 14.3

Sintomas nucleares x acessórios

Sintomas nucleares

- Déficit de atenção
- Desorientação
- Perturbações do ciclo sono-vigília
- Comprometimento da memória
- Anormalidades do pensamento
- Comprometimento visuoespacial
- Alterações motoras
- Distúrbios da linguagem

Sintomas acessórios

- Transtornos perceptivos (alucinações e ilusões)
- Delírios
- Alterações afetivas

Fonte: Com base em Meagher e colaboradores.²⁸

ESTABELECENDO O DIAGNÓSTICO

O diagnóstico é primariamente clínico, apoiado pela história e pelo exame físico completo (incluindo avaliação neurológica). Deve ser calcado nos critérios diagnósticos do DSM-5 e/ou da *Classificação internacional de doenças e problemas relacionados à saúde* (CID-10), mas está sujeito a algum grau de subjetividade. Na prática clínica, apenas 30 a 60% dos pacientes com *delirium* são corretamente identificados.²⁹⁻³¹ Quando o quadro clínico é característico, o diagnóstico pode ser feito mesmo que uma causa subjacente não tenha sido identificada. O uso de escalas e de entrevistas semiestruturadas é uma ferramenta útil. A realização de exames complementares, como o eletrencefalograma, pode auxiliar no diagnóstico diferencial e na identificação etiológica.

Os critérios para *delirium* foram revisados para a quinta edição do DSM¹ e encontram-se expostos no Quadro 14.4. É interessante notar, contudo, que, quando comparados às antigas definições de *delirium* do DSM-IV, os novos critérios parecem ser menos inclusivos e deixam de diagnosticar entre 11 e 70% dos casos englobados pelas diretrizes anteriores.³² A retirada do termo “consciência”, com maior foco nas alterações de atenção, pode estreitar o espectro de pacientes diagnosticados, dependendo de como esse critério for interpretado. Recomenda-se a leitura inclusiva dos Critérios A e D, de modo que pacientes não comatosos, mas que apresentam dificuldade para despertar e serem submetidos a avaliação cognitiva ou entrevista, sejam considerados com um quadro de desatenção. A inclusão desses indivíduos está mais bem alinhada com a evidência científica atual e com a prática clínica e resultará em maior segurança para os pacientes por meio de maior espectro de identificação e prevenção de *delirium*.^{32,33}

QUADRO 14.4

Critérios diagnósticos para *delirium*, segundo o DSM-5

- A. Perturbação da atenção (i.e., capacidade reduzida para direcionar, focalizar, manter e mudar a atenção) e da consciência (menor orientação para o ambiente).
- B. A perturbação se desenvolve em um período breve de tempo (em geral, de horas a poucos dias), representa uma mudança da atenção e da consciência basais e tende a oscilar quanto à gravidade ao longo de um dia.
- C. Perturbação adicional na cognição (p. ex., déficit de memória, desorientação, linguagem, capacidade visuoespacial ou percepção).
- D. As perturbações dos Critérios A e C não são mais bem explicadas por outro transtorno neurocognitivo preexistente, estabelecido ou em desenvolvimento, e não ocorrem no contexto de um nível gravemente diminuído de estimulação, como no coma.
- E. Há evidências, a partir da história, do exame físico ou de achados laboratoriais, de que a perturbação é uma consequência fisiológica direta de outra condição médica, intoxicação ou abstinência de substância (i.e., devido a uma droga de abuso ou a um medicamento), de exposição a uma toxina ou de que ela se deva a múltiplas etiologias.

Fonte: Com base em American Psychiatric Association.¹

INSTRUMENTOS PARA AUXÍLIO DIAGNÓSTICO

Várias escalas e entrevistas semiestruturadas foram desenvolvidas para auxiliar o clínico na avaliação e no diagnóstico. O uso de instrumentos diagnósticos, com fácil e rápida aplicação em pacientes no leito, pode definir melhor quais pacientes devem receber interconsulta formal e tratamento específico.³⁴

CAM (Confusion Assessment Method) – É uma escala desenvolvida para auxiliar médicos não psiquiatras a identificarem *delirium* (Quadro 14.5). Em função de sua acurácia, rápida aplicação e facilidade, tornou-se o instrumento padronizado mais amplamente utilizado na prática clínica e para pesquisa nas últimas duas décadas. Mostra sensibilidade de 94% e especificidade de 89%.³⁵

QUADRO 14.5

Versão em português do CAM (Confusion Assessment Method)

1. Início agudo

Há evidência de mudança aguda do estado mental de base do paciente? ()

2. Distúrbio da atenção*

2a. O paciente teve dificuldade em focalizar sua atenção, por exemplo, distraiu-se facilmente ou teve dificuldade em acompanhar o que estava sendo dito? ()

- Ausente em todo o tempo da entrevista ()
- Presente em algum momento da entrevista, porém, de forma leve ()
- Presente em algum momento da entrevista, de forma marcante ()
- Incerto ()

2b. Se presente ou anormal, esse comportamento variou durante a entrevista, isto é, tendeu a surgir e desaparecer ou aumentar e diminuir de gravidade?

- Sim ()
- Não ()
- Incerto ()
- Não aplicável ()

2c. Se presente ou anormal, descreva o comportamento:

3. Pensamento desorganizado

O pensamento do paciente era desorganizado ou incoerente, com a conversação dispersiva ou irrelevante, fluxo de ideias pouco claro ou ilógico, ou mudança imprevisível de assunto?

4. Alteração do nível de consciência

Em geral, como você classificaria o nível de consciência do paciente?

- Alerta (normal) ()
- Vigilante (hiperalerta, hipersensível a estímulos ambientais, assustando-se facilmente) ()
- Letárgico (sonolento, facilidade para despertar) ()
- Estupor (dificuldade para despertar) ()
- Coma ()
- Incerto ()

5. Desorientação

O paciente ficou desorientado durante a entrevista, por exemplo, pensando que estava em outro lugar que não o hospital, que estava no leito errado ou tendo noção errada da hora do dia?

6. Distúrbio (prejuízo) da memória

O paciente apresentou problemas de memória durante a entrevista, como incapacidade de se lembrar de eventos do hospital ou dificuldade para se lembrar de instruções?

7. Distúrbios de percepção

O paciente apresentou sinais de distúrbios de percepção, como alucinações, ilusões ou interpretações errôneas (pensando que algum objeto fixo se movimentava)?

8. Agitação psicomotora

Parte 1 – Durante a entrevista, o paciente apresentou aumento anormal da atividade motora, como agitação, beliscar de cobertas, tamborilar com os dedos ou mudança súbita e frequente de posição?

Retardo psicomotor

Parte 2 – Durante a entrevista, o paciente apresentou diminuição anormal da atividade motora, como letargia, olhar fixo no vazio, permanência na mesma posição por longo tempo ou lentidão exagerada de movimentos?

9. Alteração do ciclo sono-vigília

O paciente apresentou sinais de alteração do ciclo sono-vigília, como sonolência diurna excessiva e insônia noturna?

* As perguntas listadas depois deste tópico foram repetidas para cada item quando aplicáveis.

Miniexame do Estado Mental (MEEM) – Também é utilizado para triagem de *delirium*, mas escores baixos não necessariamente o indicam. Além disso, apoia-se de maneira significativa na avaliação da orientação (que nem sempre está comprometida) e não avalia adequadamente a atenção (aspecto central da síndrome). O MEEM encontra-se em anexo do Capítulo 10.

Delirium Rating Scale – Revised (DRS) – A versão revisada da DRS é amplamente utilizada e permite avaliar a gravidade dos sintomas no delirium. Apresenta grande sensibilidade (92,6%), especificidade (94,6%) e confiabilidade entre avaliadores (0,9-1,0).³⁸

TIPOS CLÍNICOS (SUBTIPOS MOTORES)

O *delirium* é classicamente dividido em três diferentes subtipos: hiperativo (ou hipervigilante), hipoativo e misto (que combina elementos dos dois anteriores).

O subtipo **hiperativo** é a forma mais exuberante. Pacientes com *delirium* hiperativo são, em geral, inquietos e agitados, apresentando frequentemente delírios, ilusões, alucinações, atividades estereotipadas, logorreia, hiperatividade motora e agressividade. Um exemplo típico de *delirium* hiperativo é o *delirium tremens* (secundário à abstinência alcoólica).

Já os pacientes com *delirium* **hipoativo** interagem pouco com o ambiente e encontram-se letárgicos e sonolentos. Apresentam retardo motor e verbal, baixa responsividade e lentificação psíquica.³⁹ Como o quadro clínico desses pacientes é menos exuberante, o diagnóstico pode passar despercebido com maior frequência ou o paciente é erroneamente diagnosticado com depressão.⁴⁰ Alguns autores associam esse subtipo a pior prognóstico.⁴¹

O interesse nessa classificação deriva da possível associação com diferenças na neuropatogenia, no diagnóstico, no tratamento e no prognóstico. Em função da pequena concordância das diferentes definições de subtipos motores, Meagher e colaboradores²⁵ propuseram um novo método de categorização desses pacientes – a Escala de Subtipos Motores de *Delirium* (DMSS – *Delirium* Motor Subtype Scale) (Quadro 14.6). Ela se apoia exclusivamente em alterações motoras “puras”, relativizando sintomas psíquicos sem relação direta com o grau de atividade, e parece ser uma opção mais objetiva para a prática clínica.⁴²

QUADRO 14.6

Escala de Subtipos Motores de *Delirium* (*Delirium* Motor Subtype Scale)

Delirium hiperativo: se houver evidência definitiva de surgimento, nas últimas 24 horas (e isso deve ser diferente do basal pré-*delirium*), de pelo menos dois dos seguintes:

- Aumento da quantidade de atividade motora (excessivo nível de atividades)
- Perda do controle de atividades (torna-se incapaz de manter nível de atividades adequado a circunstâncias)
- Inquietação (queixa-se de inquietação ou parece agitado)
- Peregrinação (move-se sem direção ou propósito claros)

Delirium hipoativo: se houver evidência definitiva de surgimento, nas últimas 24 horas (e isso deve ser diferente do basal pré-*delirium*), de dois ou mais dos seguintes:

- Diminuição da quantidade de atividades (menos atividade que o habitual, como se mexer menos)
- Diminuição na velocidade das ações (lentidão para iniciar ou realizar movimentos)
- Redução do alerta quanto ao ambiente (ausência relativa de reação emocional ou passividade quanto ao ambiente)
- Diminuição quantitativa da fala/do discurso (não disposto a falar, com discurso restrito ao mínimo)
- Diminuição da velocidade do discurso (fala mais lentamente que o habitual)
- Letargia (menos reativo ao ambiente)
- Redução do alerta/retraimento (parece desconectado do ambiente e do seu significado)

Delirium misto: se houver evidência dos dois tipos (hiper e hipoativo) nas últimas 24 horas

Sem subtipo motor: sem evidências de *delirium* hiper ou hipoativo nas últimas 24 horas

Fonte: Meagher e colaboradores²⁵ e Trzepacz e colaboradores.⁴²

AValiação complementar

Exames complementares são úteis tanto na investigação das patologias associadas quanto no diagnóstico diferencial com outros transtornos. Destaca-se o uso do eletrencefalograma (EEG), que, no *delirium*, mostra um padrão característico de lentificação global (salvo exceções, como o *delirium tremens*).⁴²

A investigação complementar deve ser guiada pela avaliação clínica inicial. Como esses pacientes costumam apresentar múltiplas patologias, o quadro deve ser reavaliado periodicamente (Quadro 14.7).

QUADRO 14.7

Guia para a investigação de pacientes com *delirium*

Investigações necessárias para a maioria dos pacientes	
Mensuração da temperatura	Infecção
Exame de urina	Infecção urinária (investigar também a presença de sangue, proteínas, leucócitos e nitratos)
Glicemia	Hipo/hiperglicemia, diabetes
Eletrocardiograma	Infarto agudo do miocárdio, arritmias
Raio X de tórax	Pneumonia, insuficiência cardíaca, câncer
Hemograma	Anemia, leucocitose
Ureia e eletrólitos	Desidratação, função renal, distúrbio hidreletrolítico (alterações em sódio, potássio, magnésio e cálcio)
Culturas	Urina, escarro, sangue (se febril ou gravemente doente)
Investigações necessárias para vários pacientes	
Gasometria	Hipoxia, exclusão de hipercapnia entre pacientes recebendo oxigênio
Hemocultura	Infecção oculta
Testes toxicológicos (drogas)	Possibilita diagnóstico retrospectivo
Proteína C reativa	Infecção
Investigações ocasionalmente úteis	
Hemossedimentação	Inflamação (p. ex., arterite de células gigantes)
Tomografia computadorizada de crânio	Lesões cerebrais focais
Eletrencefalograma	Útil para confirmar o diagnóstico e estabelecer diagnóstico diferencial
Função tireoidiana	Hipo/hipertireoidismo
B12 e folato	Deficiência pode ocorrer mesmo quando hemograma é normal

Fonte: Almeida.²¹

DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL

Em função de seu amplo espectro sintomático e de diferentes apresentações clínicas, o quadro clínico de *delirium* pode mimetizar uma série de transtornos mentais. O Quadro 14.8 ilustra as principais condições cujo diagnóstico diferencial precisa ser feito, bem como as características que ajudam a diferenciá-las.

QUADRO 14.8
Características clínicas do *delirium* em comparação a demência, depressão e esquizofrenia

Características	<i>Delirium</i>	Demência	Depressão	Esquizofrenia
Início	Agudo	Insidioso	Variável	Variável
Curso	Flutuante	Progressivo, com perdas cognitivas cumulativas	Episódios que se repetem, sem deterioração	Surtos, com possível deterioração
Reversibilidade	Sim	Não	Sem prejuízos	Com prejuízos afetivos e da personalidade
Nível de consciência	Prejudicado	Claro	Claro	Claro, pode haver perplexidade
Atenção/Memória	Desatenção marcante, memória ruim	Memória progressivamente pior, sem desatenção marcante	Atenção ruim, memória pouco prejudicada	Atenção ruim, memória pouco prejudicada
Delírio	Efêmero, fragmentado	Paranoide, pouco elaborado	Congruente com o humor	Frequente, pode ser elaborado

Fonte: Dalgallarrondo.⁴³

DELIRIUM X DEMÊNCIA

A distinção entre *delirium* e demência é de particular importância, pois essas síndromes apresentam uma intersecção de elementos sintomáticos, o que dificulta o diagnóstico diferencial. Além disso, ambas podem ocorrer de maneira sobreposta – pacientes com prejuízo cognitivo prévio são mais suscetíveis a apresentar quadros de *delirium*, em função da diminuição da reserva cerebral funcional. Entre pacientes idosos, demência e *delirium* ocorrem de maneira concomitante em até dois terços dos casos.^{18,32}

Historicamente, esses transtornos são diferenciados com base em seu curso temporal e sua reversibilidade, com *delirium* instalando-se de maneira aguda e apresentando flutuação da gravidade dos sintomas, enquanto demência apresenta um curso deteriorante.⁴⁴ O sintoma cognitivo cardinal do *delirium* é a desatenção, enquanto, na demência, o principal comprometimento é da esfera da memória, com atenção relativamente preservada. Alterações da consciência também favorecem o diagnóstico de *delirium*.

Essa distinção torna-se ainda mais relevante tendo em vista a discussão atual de que *delirium* poderia, *per se*, culminar com prejuízo cognitivo após sua resolução, mesmo sem evidências claras de quadro demencial anterior a sua instalação.⁴⁵

DELIRIUM X ESQUIZOFRENIA

Pacientes com quadros psicóticos agudos podem apresentar intensa desorganização do comportamento, sendo, por vezes, difícil distingui-los de pacientes com *delirium*.

Delirium costuma predominar em pacientes idosos, enquanto esquizofrenia geralmente inicia-se em adultos jovens, que, muitas vezes, apresentam traços específicos de personalidade pré-mórbida. Nos quadros de esquizofrenia, além do desenvolvimento mais insidioso, o curso não costuma apresentar flutuação da sintomatologia, tampouco alteração da consciência e da orientação, como ocorre no *delirium*. Quando um paciente com *delirium* apresenta delírios (juízos patologicamente falsos), estes costumam ser mais fragmentários e fugazes. As alucinações na esquizofrenia são predominantemente auditivas, enquanto, no *delirium*, costumam ser visuais e táteis.

DELIRIUM X TRANSTORNOS DO HUMOR (MANIA/DEPRESSÃO)

À semelhança do que ocorre entre pacientes com esquizofrenia, pacientes em mania, com intensa agitação motora, podem mimetizar quadros de *delirium*. Na mania, o paciente apresenta-se agitado, irritável, eufórico e pode manifestar sintomas psicóticos. Esses sintomas costumam ser mais estáveis ao longo do tempo, diferentemente do *delirium*, que apresenta flutuação marcante.

Pacientes com *delirium* hipoativo frequentemente são interpretados como apresentando um quadro depressivo. Como quadros confusionais agudos costumam ocorrer em pacientes com patologias clínicas graves, como as oncológicas, deve-se estar atento para distinguir entre processos de luto ou de ajustamento e pacientes apáticos de lentificados em função de um quadro orgânico.

Tratamento

O processo de identificação e tratamento de possíveis causas associadas deve ser rápido. Ademais, o paciente deve receber tratamento específico para o transtorno, incluindo medidas não medicamentosas (manejo ambiental e orientação da equipe e de familiares) e farmacológicas (sedação quando necessário).

Estratégias de profilaxia, abordando fatores de risco comumente associados ao seu desenvolvimento, mostraram-se efetivas e devem ser implementadas.

Profilaxia/Prevenção

A crescente compreensão dos fatores predisponentes e precipitantes de *delirium* tem tornado as estratégias de prevenção cada vez mais importantes na abordagem de pacientes de risco. Exposição a medicamentos, deficiência visual e/ou auditiva, privação de sono, controle inadequado da dor, desidratação, desnutrição, uso de instrumentos invasivos (cateteres, tubos, drenos), imobilidade, contenção física e “polifarmácia” são fatores modificáveis, cujo controle pode influenciar na incidência e na gravidade do quadro confusional.^{16,46}

Inouye e colaboradores⁴⁷ estudaram o impacto de intervenções profiláticas não farmacológicas, elaborando um protocolo de cuidados voltados a alguns desses fatores, que comumente são preditivos do desenvolvimento da síndrome. As estratégias centrais incluíram atividades terapêuticas, reorientação, otimização do sono, exercícios e mobilização do paciente, hidratação oral, auxílio visual e auditivo. Os pacientes submetidos a essas intervenções foram comparados com aqueles que receberam cuidados habituais. As taxas de incidência e o número total de dias de *delirium* foram significativamente menores no primeiro grupo.

O USO PROFILÁTICO DE PSICOFÁRMACOS

Atualmente, uma série de trabalhos relata o uso de haloperidol, antipsicóticos atípicos e inibidores da acetilcolinesterase antes de procedimentos cirúrgicos em pacientes com alto risco para *delirium*. Apesar de alguns estudos apontarem resultados positivos quanto ao uso de antipsicóticos como estratégia profilática,^{48,49} uma grande revisão sistemática com metanálise, realizada por Neufeld e colaboradores,⁵⁰ não apontou relação entre o uso dessa classe de fármacos e a prevenção de *delirium*, a redução da duração ou da gravidade do quadro e a redução da mortalidade ou do tempo de internação hospitalar.

Outras estratégias que já se mostraram promissoras na prevenção de *delirium* pós-operatório também falharam. Talvez o maior exemplo seja o uso de rivastigmina, um inibidor da acetilcolinesterase, cujo mecanismo de ação apontava ser plausível que seu uso diminuiria a incidência de quadros confusionais, com pesquisas demonstrando resultados iniciais promissores. Contudo, um estudo randomizado realizado por Van Eijk e colaboradores⁵¹ mostrou que a rivastigmina parece promover *delirium* e se associou a maior mortalidade.

Dexmedetomidina

Em meio a essa miríade de resultados negativos, Su e colaboradores⁵² encontraram, em um estudo duplo-cego randomizado envolvendo 700 pacientes, que pequenas doses de dexmedetomidina, administradas de forma profilática, resultaram em uma redução absoluta de 13% (de 22 para 9%) na incidência de *delirium* pós-operatório na UTI. Devemos, contudo, considerar esse resultado com cautela, uma vez que parece ser contraintuitivo, na prática diária, administrar um sedativo para pacientes sem *delirium*.

A dexmedetomidina (Precedex®) é o fármaco com ação agonista seletiva nos receptores alfa-2-adrenérgicos, resultando em um efeito sedativo e analgésico, evitando, assim, o uso de opioides em pacientes que necessitam de suporte ventilatório. Como não causa depressão respiratória significativa, é considerada uma opção atrativa para sedação (de curta ou longa duração) de pacientes recebendo cuidados intensivos. Além de apresentar bom perfil de tolerabilidade, seu uso parece ter efeito favorável com relação à incidência de *delirium*.⁵³

Os efeitos adversos mais comumente observados são hipotensão, hipertensão e bradicardia.⁵³ Em função destes, é recomendada cautela quando a droga é usada em idosos, em pacientes com doenças cardíacas ou, ainda, em pacientes que já apresentaram bradicardia quando em uso de dexmedetomidina.⁵⁴

Os pacientes em uso de dexmedetomidina habitualmente acordam de maneira mais fácil, são mais cooperativos e se comunicam melhor quando comparados com pacientes recebendo midazolam ou propofol.⁵³ Em comparação com outras drogas (como lorazepam), a dexmedetomidina demonstrou menor risco de *delirium* em pacientes em ventilação mecânica na UTI.⁵⁵ Além disso, em um estudo em que foi confrontada com o haloperidol, pacientes em uso de dexmedetomidina apresentaram menor tempo de permanência na UTI.⁵⁶

De forma geral, os achados envolvendo o uso profilático de psicofármacos como estratégia de prevenção de quadros confusionais são cercados de vieses em função da dificuldade em uniformizar os estudos, presença ou não de prejuízo cognitivo ou demência prévia, qual antipsicótico foi usado, e outros confundidores, como *delirium* associado a anestesia. Atualmente, nenhuma medida psicofarmacológica é universalmente aprovada para profilaxia de *delirium* pós-operatório.

TRATAMENTO NÃO FARMACOLÓGICO

A abordagem não farmacológica de pacientes com *delirium* exige um esforço combinado de familiares e cuidadores, proporcionando um ambiente adequado à melhora clínica. Deve ser multiprofissional, incluindo enfermeiros, psicólogos, médico assistente, psiquiatra e outros profissionais que possam estar envolvidos com os cuidados. Embora não haja evidências de que o ambiente em si cause *delirium*, condições ambientais podem exacerbá-lo.²²

Estas estratégias devem ser utilizadas sempre que possível, pois, apesar de o impacto de algumas delas na evolução dos pacientes não ser claro, são de implementação relativamente simples e não provocam efeitos adversos:^{22,57}

- Prover um ambiente calmo e confortável, reduzindo possíveis barulhos e ruídos (de monitores, televisores, rádios). O paciente deve ser submetido a um nível adequado de estimulação sensorial, uma vez que tanto a estimulação excessiva quanto a ausência de estimulação (ambientes demasiadamente silenciosos) podem piorar o quadro.
- Fornecer subsídios para que o paciente se oriente. A equipe e os familiares devem ser orientados a, no contato com o paciente, informá-lo quanto à data e ao lugar com frequência. Além disso, quando possível, devem ser disponibilizados elementos que permitam a orientação, como calendários e relógios.
- Promover a presença frequente de um acompanhante familiar.
- Minimizar mudanças no ambiente e na equipe assistencial.
- Permitir que o paciente tenha períodos ininterruptos de descanso à noite, melhorando seu ciclo sono-vigília. A atemporalidade do ambiente pode ser fatigante e agravar distúrbios do sono, o que pode ser minimizado com a presença de janelas ou de iluminação que oscile de intensidade entre o dia e a noite.
- Quadros confusionais podem ser agravados por deficiências visual e auditiva. O paciente deve ficar com seus óculos e aparelho auditivo quando possível.

TRATAMENTO FARMACOLÓGICO

Uma vez que existem poucos estudos bem estruturados para avaliar a eficácia e a segurança dos diferentes fármacos atualmente disponíveis para o manejo dos casos de *delirium*, o uso dessas medicações, em grande parte, apoia-se em conhecimentos empíricos. O uso de antipsicóticos (neurolépticos) constitui a intervenção farmacológica de primeira linha. Benzodiazepínicos podem ser usados em casos específicos. Contudo, nenhum fármaco tem a indicação específica da US Food and Drug Administration (FDA) para o tratamento de *delirium*.⁵⁸

Medicações sedativas podem ofuscar o quadro mental e comprometer a avaliação de mudanças na função cognitiva. Apesar disso, psicotrópicos são frequentemente utilizados nesses pacientes, muitas vezes antes da interconsulta psiquiátrica. Seu uso parece relacionar-se mais com a gravidade das alterações comportamentais do que com a gravidade da confusão mental.⁵⁹

Antipsicóticos

Os antipsicóticos vêm sendo usados há muitos anos no tratamento de *delirium*, remediando as alterações comportamentais e a agitação psicomotora relacionadas ao quadro. Contudo, existem controvérsias quanto a sua eficácia⁵⁰ e até mesmo especulações de que essas drogas poderiam piorar os sintomas cognitivos e prolongar a duração do quadro confusional, além de não existirem evidências de que seu uso melhore o prognóstico dos pacientes.⁶⁰

O haloperidol (bloqueador de receptores D2 de alta potência) é o medicamento mais estudado, considerado o padrão-ouro em função de apresentar poucos efeitos anticolinérgicos, baixos níveis de hipotensão ortostática e de sedação e disponibilidade em diferentes dosagens e apresentações (pode ser administrado VO, IM e IV).⁶¹ Contudo, seu uso pode causar efeitos indesejáveis, principalmente extrapiramidais, como distonia aguda, parkinsonismo, acatisia e síndrome neuroléptica maligna, além de alterações da condução cardíaca.

Pacientes mais calmos podem ser medicados por via oral (comprimido ou gotas) e costumam apresentar melhora do comportamento mesmo com doses baixas, como 1 a 2 mg de haloperidol por dia. Caso não seja obtida a tranquilização, aumenta-se progressivamente a dose. Pacientes com inversão do ciclo sono-vigília se beneficiam de doses noturnas. Pacientes mais agitados e inquietos, com alteração grave do comportamento, necessitam de haloperidol IM ou IV. Mesmo não sendo claro o limite diário desse medicamento e de haver relatos na literatura demonstrando seu uso em altas doses, no serviço de emergência psiquiátrica do Hospital das Clínicas (HC) da Unicamp, não se costuma utilizar mais de 5 mg por aplicação ou doses maiores que 20 a 30 mg/dia.

Apesar de não ser aprovado pela FDA, o haloperidol vem sendo administrado por via IV há muitos anos. Em especial para pacientes gravemente agitados, a administração IV pode ser necessária para rápida tranquilização. Contudo, é imperativo atentar a possíveis alterações cardíacas associadas a seu uso, como mostra o Quadro 14.9.

QUADRO 14.9

Cuidados no uso de haloperidol IV para pacientes agitados com *delirium*

✓ Checar intervalo QTc pré-haloperidol

- Se QTc > 450 ms, o haloperidol pode ser utilizado com muita cautela, quando o benefício superar claramente os potenciais riscos associados a sua administração.
- Se QTc > 500 ms, considerar outras opções.

✓ Checar níveis de potássio e magnésio, corrigindo distúrbios

- Tentar alcançar potássio > 4 mEq/L e magnésio > 2 mEq/L.

✓ Administrar doses de haloperidol (0,5-10 mg) com base no nível de agitação, na idade e no tamanho do paciente

✓ Reavaliar o intervalo QTc constantemente para garantir que este não está se prolongando

- Se o intervalo QTc aumentar 25% em relação ao traçado de base ou tornar-se > 500 ms, considerar alternativas para o tratamento.

Fonte: Com base em Stern e colaboradores.⁶²

O uso de antipsicóticos atípicos vem ganhando espaço no tratamento de *delirium* em função do perfil mais favorável de efeitos colaterais, como menores taxas de sintomas extrapiramidais. Uma recente revisão sistemática da Cochrane sobre o uso de antipsicóticos no tratamento de *delirium* não encontrou diferença em termos de efetividade entre o haloperidol (em baixas doses) e os antipsicóticos atípicos olanzapina e risperidona. Contudo, doses altas de haloperidol associaram-se a maior incidência de efeitos colaterais, principalmente parkinsonismo.⁶³

Com relação ao uso de quetiapina, um estudo duplo-cego, randomizado e controlado, realizado por Devlin e colaboradores,⁶⁴ encontrou resultados que sugerem que seu uso pode estar associado a resolução mais rápida do *delirium* na UTI, redução do tempo de confusão mental e agitação, além de melhores condições na ocasião da alta em comparação a pacientes que receberam apenas haloperidol.

Ainda assim, como não há evidências claras de superioridade em termos de efetividade terapêutica entre as diferentes classes de antipsicóticos (típicos e atípicos), outros fatores devem guiar a escolha da medicação, destacando-se os seguintes:⁶⁵

- perfil de efeitos adversos
- tolerabilidade
- vulnerabilidade do paciente (p. ex., idade, comorbidades)
- interações medicamentosas
- vias de administração

Benzodiazepínicos

O uso de benzodiazepínicos para o tratamento de *delirium* é reservado a casos específicos, como de *delirium* secundário a abstinência de álcool ou de sedativos/hipnóticos. Eles são úteis também quando se deseja evitar possíveis efeitos adversos dos antipsicóticos (como acatisia, sintomas anticolinérgicos e desenvolvimento ou piora de sintomas extrapiramidais), quando se deseja aumentar o limiar convulsivo (os neurolépticos diminuem o limiar, com risco de ocorrência de crises convulsivas) ou quando há desejo de maior sedação, na tentativa de controle dos distúrbios psicomotores.²²

Mesmo nos casos em que há indicação para o uso de benzodiazepínicos, como o *delirium* frequentemente é multietiológico, o uso concomitante de antipsicóticos pode ser necessário.⁶⁶ Deve-se dar preferência para benzodiazepínicos de meia-vida curta e sem metabólitos ativos, já que o uso desses fármacos pode piorar a confusão mental e até mesmo aumentar o risco de *delirium*.⁶⁷ Em nosso serviço, damos preferência ao uso de lorazepam em doses baixas, em especial quando há inversão grave do ciclo sono-vigília, pelo perfil favorável de metabolização, meia-vida intermediária e ausência de metabólitos ativos.

O uso de benzodiazepínicos na abstinência alcoólica é mais bem descrito no Capítulo 20.

OUTRAS INTERVENÇÕES

Vitaminas

Carência vitamínica é uma causa de *delirium*, e espera-se que essa condição seja revertida com a reposição da vitamina deficiente. Em função da alta prevalência de alcoolismo na população brasileira, vale destacar quadros confusionais secundários à carência de tiamina. Encefalopatia de Wernicke deve sempre ser considerada como diagnóstico diferencial em quadros como *delirium tremens*, e, caso se suspeite dessa condição, o paciente deve receber tiamina parenteral em doses altas.⁶⁸

PROGNÓSTICO

O prognóstico de pacientes idosos que desenvolvem *delirium* tem sido objeto de discussão na literatura médica. Uma questão fundamental é se o desenvolvimento de *delirium* é apenas um marcador de uma doença clínica subjacente ou se seu desenvolvimento contribui como fator independente para desfechos mais sombrios.⁶⁰

Witlox e colaboradores,⁶⁹ em uma metanálise, demonstraram que a ocorrência de *delirium* associou-se, no seguimento de longo prazo de pacientes idosos, a maior mortalidade e maior risco de institucionalização e de demência, independentemente de idade, sexo, presença de demência, comorbidade ou gravidade da doença de base. Em outro estudo, realizado por Inouye e colaboradores,⁴⁵ que envolveu pacientes idosos preservados cognitivamente (sem demência) e submetidos a cirurgia cardíaca eletiva, encontrou-se que, no seguimento de longo prazo (36 meses), o desempenho cognitivo foi significativamente inferior no grupo de pacientes que desenvolveu *delirium* pós-operatório, mesmo com o controle de confundidores, como outras intercorrências médicas e complicações pós-operatórias. Nos pacientes com prejuízo cognitivo preexistente, a trajetória do declínio cognitivo foi substancialmente agravada após o desenvolvimento de *delirium*.

Os resultados apontam que o *delirium* pode servir como sólido marcador de pacientes com reserva cognitiva baixa e risco aumentado de perda cognitiva acelerada no seguimento de longo prazo. Independentemente do caráter causal, esses dados ilustram a gravidade clínica relacionada ao desenvolvimento de *delirium* e reforçam a importância para a vigilância diagnóstica e a utilização de estratégias de prevenção no hospital geral.

REFERÊNCIAS

1. American Psychiatric Association. Manual diagnóstico e estatístico de transtornos mentais: DSM-5. 5. ed. Porto Alegre: Artmed; 2014.
2. World Health Organization. International statistical classification of diseases and related health problems. 10th ed. Geneva: WHO; 1992.
3. Trzepacz PT, Meagher DJ, Wise MG. Aspectos neuropsiquiátricos do delirium. In: Yudofsky SC, Hales RE, editores. Neuropsiquiatria e neurociências. 4. ed. Porto Alegre: Artmed; 2006.
4. Maldonado JR. Delirium in the acute care setting: characteristics, diagnosis and treatment. *Crit Care Clin*. 2008;24(4):657-722, vii.
5. Flacker JM, Cummings V, Mach JR, Bettin K, Kiely DK, Wei J. The association of serum anticholinergic activity with delirium in elderly medical patients. *Am J Geriatr Psychiatry*. 1998;6(1):31-41.
6. Lawlor PG, Gagnon B, Mancini IL, Pereira JL, Hanson J, Suarez-Almazor ME, et al. Occurrence, causes, and outcome of delirium in patients with advanced cancer. *Arch Intern Med*. 2000;160(6):786-94.
7. Van Der Mast RC, Van Den Broek WW, Fekkes D, Pepplinkhuizen L, Habbema JD. Is delirium after cardiac surgery related to plasma amino acids and physical condition? *J Neuropsychiatry Clin Neurosci*. 2000;12(1):57-63.
8. Casarett DJ, Inouye SK. Diagnosis and management of delirium near the end of life. *Ann Intern Med*. 2001;135(1):32-40.
9. Turkel SB, Trzepacz PT, Tavaré CJ. Comparing symptoms of delirium in adults and children. *Psychosomatics*. 2006;47(4):320-4.
10. Pandharipande P, Cotton BA, Shintani A, Thompson J, Costabile S, Truman Pun B, et al. Motoric subtypes of delirium in mechanically ventilated surgical and trauma intensive care unit patients. *Intensive Care Med*. 2007;33(10):1726-31.
11. Angels EM, Robinson TN, Biffel WL, Johnson J, Moss M, Tran ZV, et al. Risk factors for delirium after major trauma. *Am J Surg*. 2008;196(6):864-9; discussion 869-70.
12. Santos FS, Wahlund LO, Varli F, Velasco IS, Jönghagen ME. Incidence, clinical features and subtypes of delirium in elderly patients treated for hip fractures. *Dement Geriatr Cogn Disord*. 2005;20(4):231-7.
13. Kalisvaart KJ, Vreeswijk R, De Jonghe JFM, Van Der Ploeg T, Van Gool WA, Eikelenboom P. Risk factors and prediction of postoperative delirium in elderly hip-surgery patients: implementation and validation of a medical risk factor model. *J Am Geriatr Soc*. 2006;54(5):817-22.
14. Uguz F, Kayrak M, Çiçek E, Kayhan F, Ari H, Altunbas G. Delirium following acute myocardial infarction: incidence, clinical profiles, and predictors. *Perspectives in Psychiatric Care*. 2010;46(2):135-42.
15. McManus J, Pathansali R, Stewart R, Macdonald A, Jackson S. Delirium post-stroke. *Age Ageing*. 2007;36(6):613-8.

16. Inouye SK, Rushing JT, Foreman MD, Palmer RM, Pompei P. Does delirium contribute to poor hospital outcomes? A three-site epidemiologic study. *J Gen Intern Med.* 1998;13(4):234-42.
17. Korevaar JC, Van Munster BC, De Rooij SE. Risk factors for delirium in acutely admitted elderly patients: a prospective cohort study. *BMC Geriatrics.* 2005;5(6).
18. Wahlund L, Björlin GA. Delirium in clinical practice: experiences from a specialized delirium ward. *Dement Geriatr Cogn Disord.* 1999;10(5):389-92.
19. Lawlor PG, Fainsinger RL, Bruera ED. Delirium at the end of life: critical issues in clinical practice and research. *JAMA.* 2000;284(19):2427-9.
20. Francis J, Martin D, Kapoor WN. A prospective study of delirium in hospitalized elderly. *JAMA.* 1990;263(8):1097-101.
21. Almeida OP. Confusão mental e demência. In: Botega NJ, editores. *Prática psiquiátrica no hospital geral: interconsulta e emergência.* 2. ed. Porto Alegre: Artmed; 2006.
22. American Psychiatric Association. Practice guideline for the treatment of patients with delirium. *Am J Psychiatry.* 1999;156(Suppl):1-20.
23. Trzepacz P. Update on the neuropathogenesis of delirium. *Dement Geriatr Cogn Disord.* 1999;10(5):330-4.
24. Hsieh TT, Fong TG, Marcantonio ER, Inouye SK. Cholinergic deficiency hypothesis in delirium: a synthesis of current evidence. *J Gerontol A Biol Sci Med Sci.* 2008;63(7):764-72.
25. Meagher D, Moran M, Raju B, Leonard M, Donnelly S, Saunders J. A new data-based motor subtype schema for delirium. *J Neuropsychiatry Clin Neurosci.* 2008;20(2):185-93.
26. Sandberg O, Gustafson Y, Brännström B, Bucht G. Clinical profile of delirium in older patients. *J Am Geriatr Soc.* 1999;47(11):1300-6.
27. Cutting J. The phenomenology of acute organic psychosis. Comparison with acute schizophrenia. *Br J Psychiatry.* 1987;151:324-32.
28. Meagher DJ, Moran M, Raju B, Gibbons D, Donnelly S, Saunders J, et al. Phenomenology of delirium. Assessment of 100 adult cases using standardised measures. *Br J Psychiatry.* 2007;190:135-41.
29. Boland RJ, Diaz S, Lamdan RM, Ramchandani D, McCartney JR. Overdiagnosis of depression in the general hospital. *Gen Hosp Psychiatry.* 1996;18(1):28-35.
30. Farrel KR, Ganzini L. Misdiagnosing delirium as depression in medically ill elderly patients. *Arch Intern Med.* 1995;155(22):2459-64.
31. Inouye SK. The dilemma of delirium: clinical and research controversies regarding diagnosis and evaluation of delirium in hospitalized elderly medical patients. *Am J Med.* 1994;97(3):278-88.
32. Meagher DJ, Morandi A, Inouye SK, Ely W, Adamis D, MacLulich AJ, et al. Concordance between DSM-IV and DSM-5 criteria for delirium diagnosis in a pooled database of 768 prospectively evaluated patients using the delirium rating scale-revised-98. *BMC Med.* 2014;12(1):164.

33. Siddiqi N, House A, Holmes J, Witlox J, Eurelings L, Jonghe J, et al. The DSM-5 criteria, level of arousal and delirium diagnosis: inclusiveness is safer. *BMC Med.* 2014;12(1):141.
34. Wong CL, Holroyd-Leduc J, Simel DL. Does this patient have delirium? Value of bedside instruments. *JAMA.* 2010;304(7):779-86.
35. Wei LA, Fearing MA, Sternberg EJ, Inouye SK. The confusion assessment method (CAM): a systematic review of current usage. *J Am Geriatr Soc.* 2008;56(5):823-30.
36. Fabbri RMA, Moreira MA, Garrido R, Almeida OP. Validity and reliability of the portuguese version of the Confusion Assessment Method (CAM) for the detection of delirium in the elderly. *Arq Neuropsiquiatr.* 2001;59(2-A):175-9.
37. Inouye SK, Van Dyck CH, Alessi CA, Balkin S, Siegel AP, Horwitz RI. Clarifying confusion: the confusion assessment method. A new method for detection of delirium. *Ann Intern Med.* 1990;113(12):941-8.
38. Negreiros DP, Meleiro AMAS, Furlanetto LM, Trzepacz PT. Portuguese version of the Delirium Rating Scale-Revised-98: reliability and validity. *Int J Geriatr Psychiatry.* 2008;23(5):472-7.
39. Camus V, Burtin B, Simeone I, Schwed P, Gonthier R, Dubos G. Factor analysis supports the evidence of existing hyperactive and hypoactive subtypes of delirium. *Int J Geriatr Psychiatry.* 2000;15(4):313-6.
40. Inouye SK, Foreman MD, Mion LC, Katz KH, Cooney LM. Nurses' recognition of delirium and it's symptoms. *Arch Intern Med.* 2001;161(20):2467-73.
41. O'Keeffe ST, Lavan JN. Clinical significance of delirium subtypes in older people. *Age Ageing.* 1999;28(2):155-9.
42. Trzepacz PT, Meagher DJ, Leonard M. Delirium. In: Levenson JL, Wulsin L, Guthrie EA, editors. *The American Psychiatric Publishing textbook of psychosomatic medicine: psychiatric care of the medically ill.* 2nd ed. Arlington: American Psychiatric Publishing; 2010.
43. Dalgalarondo P. *Psicopatologia e semiologia dos transtornos mentais.* 2. ed. Porto Alegre: Artmed; 2008.
44. Meagher DJ, Leonard M, Donnelly S, Conroy M, Saunders J, Trzepacz PT. A comparison of neuropsychiatric and cognitive profiles in delirium, demential, comorbid delirium-dementia and cognitively intact controls. *J Neurol Neurosurg Psychiatry.* 2010;81(8):876-81.
45. Inouye SK, Marcantonio ER, Kosar CM, Tommet D, Schmitt EM, Trivison TG, et al. The short-term and long-term relationship between delirium and cognitive trajectory in older surgical patients. *Alzheimers Dement.* 2016;12(7):766-75.
46. Salluh JJ, Soares M, Teles JM, Ceraso D, Raimondi N, Nava VS, et al. Delirium epidemiology in critical care (DECCA): an international study. *Crit Care.* 2010;14(6):R210.
47. Inouye SK, Bogardus ST Jr, Charpentier PA, Leo-Summers L, Acampora D, Holford TR, et al. A multicomponent intervention to prevent delirium in hospitalized older patients. *N Engl J Med.* 1999;340(9):669-76.

48. Serafim RB, Bozza FA, Soares M, Do Brasil AA, Tura BR, Ely EW, et al. Pharmacologic prevention and treatment of delirium in intensive care patients: a systematic review. *J Crit Care*. 2015;30(4):799-807.
49. Fok MC, Sepehry AA, Frisch L, Sztramko R, Borger Van Der Burg BLS, Vochteloo AJH, et al. Do antipsychotics prevent postoperative delirium? A systematic review and meta-analysis. *Int J Geriatr Psychiatry*. 2015;30(4):333-44.
50. Neufeld KJ, Yue J, Robinson TN, Inouye SK, Needham DM. Antipsychotic medication for prevention and treatment of delirium in hospitalized adults: a systematic review and meta-analysis. *J Am Geriatr Soc*. 2016;64(4):705-14.
51. Van Eijk MM, Roes KC, Honing ML, Kuiper MA, Karakus A, Van Der Jagt M, et al. Effect of rivastigmine as an adjunct to usual care with haloperidol on duration of delirium and mortality in critically ill patients: a multicentre, double-blind, placebo-controlled randomised trial. *Lancet*. 2010;376(9755):1829-37.
52. Su X, Meng Z-T, Wu X-H, Cui F, Li H-L, Wang D-X, et al. Dexmedetomidine for prevention of delirium in elderly patients after non-cardiac surgery: a randomised, double-blind, placebo-controlled trial. *Lancet*. 2016;388(10054):1893-902.
53. Keating GM. Dexmedetomidine: a review of its use for sedation in the intensive care setting. *Drugs*. 2015;75(10):1119-30.
54. Cavallazzi R, Saad M, Marik PE. Delirium in the ICU: an overview. *Ann Intensive Care*. 2012;2:49.
55. Pandharipande PP, Pun BT, Herr DL, Maze M, Girard TD, Miller RR, et al. Effect of sedation with dexmedetomidine vs lorazepam on acute brain dysfunction in mechanically ventilated patients. *JAMA*. 2007;298(22):2644.
56. Reade MC, O'Sullivan K, Bates S, Goldsmith D, Ainslie WR, Bellomo R. Dexmedetomidine vs. haloperidol in delirious, agitated, intubated patients: a randomised open-label trial. *Crit Care*. 2009;13(3):R75.
57. Meagher DJ, O'hanlon D, O'mahony E, Casey PR. The use of environmental strategies and psychotropic medication in the management of delirium. *Br J Psychiatry*. 1996;168(4):512-5.
58. Alici-Evcimen Y, Breitbart W. An update on the use of antipsychotics in the treatment of delirium. *J Clin Psychiatry*. 2007;68(1):11-21.
59. Gagnon P, Allard P, Gagnon B, Mérette C, Tardif F. Delirium prevention in terminal cancer: assessment of a multicomponent intervention. *Psychooncology*. 2012;21(2):187-94.
60. Inouye SK, Westendorp RGJ, Saczynski JS. Delirium in elderly people. *Lancet*. 2014;383(9920):911-22.
61. Someya T, Endo T, Hara T, Yagi G, Suzuki J. A survey on the drug therapy for delirium. *Psychiatry Clin Neurosci*. 2001;55(4):397-401.
62. Stern TA, Fricchione GL, Cassem NH, Jellinek MS, Rosenbaum JF, editors. *Massachusetts General Hospital handbook of general hospital psychiatry*. 6th ed. Philadelphia: Saunders; 2010.

63. Lonergan E, Britton AM, Luxenberg J, Wyller T. Antipsychotics for delirium. *Cochrane Database Syst Rev*. 2007;(2):CD005594.
64. Devlin JW, Roberts RJ, Fong JJ, Skrobik Y, Riker RR, Hill NS, et al. Efficacy and safety of quetiapine in critically ill patients with delirium: a prospective, multicenter, randomized, double-blind, placebo-controlled pilot study. *Crit Care Med*. 2010;38(2):419-27.
65. Bourne RS, Tahir TA, Borthwick M, Sampson EL. Drug treatment of delirium: past, present and future. *J Psychosom Res*. 2008;65(3):273-82.
66. Meagher D, Leonard M. The active management of delirium; improving detection and treatment. *Adv Psychiatr Treat*. 2008;14(4):292-301.
67. Lin RY, Heacock LC, Bhargava GA, Forgel JF. Clinical associations of delirium in hospitalized adult patients and the role of on admission presentation. *Int J Geriatr Psychiatry*. 2010;25(10):1022-9.
68. Sechi G, Serra A. Wernicke's encephalopathy: new clinical settings and recent advances in diagnosis and management. *Lancet Neurol*. 2007;6(5):442-55.
69. Witlox J, Eurelings LS, de Jonghe JF, Kalisvaart KJ, Eikelenboom P, van Gool WA. Delirium in elderly patients and the risk of postdischarge mortality, institutionalization, and dementia: a meta-analysis. *JAMA*. 2010;304(4):443-51.

SITES SUGERIDOS

Europeandeliriumassociation.com [Internet]. Baltimore: EDA; 2016 [capturado em 27 dez. 2016]. Disponível em: <http://www.europeandeliriumassociation.com/>.

Icudelirium.org [Internet]. Nashville: ICU Delirium; c2013 [capturado em 27 dez. 2016]. Disponível em: <http://www.icudelirium.org/>.

Psychiatryonline.org [Internet]. Arlington: APA; c2016 [capturado em 27 dez. 2016]. Disponível em: <http://psychiatryonline.org/guidelines>.



Depressão

Neury José Botega
Letícia Maria Furlanetto
Renério Fraguas

Este capítulo aborda os seguintes desafios que os transtornos depressivos trazem para o médico que trabalha em hospital geral: 1) reconhecer a depressão como algo “a mais” no quadro clínico de outra doença do paciente; 2) saber como a depressão se relaciona com outras doenças clínicas, reconhecendo o potencial destas, bem como de alguns medicamentos, para causar depressão; e 3) indicar o tratamento adequado, considerando as nuances do quadro clínico, as indicações, as contraindicações e as interações dos antidepressivos com outros medicamentos.

A depressão aparece em segundo lugar entre as doenças mais incapacitantes que atingem indivíduos em idade produtiva.¹ Ela tem impacto em vários sistemas de regulação corporal, aumentando a morbidade, a mortalidade e os custos do tratamento quando há doenças clínicas concomitantes.²⁻⁵ Esse impacto torna-se ainda mais significativo se considerarmos que o diagnóstico e o tratamento adequado não são realizados na maioria dos casos.⁶

As bases biológicas da depressão têm sido amplamente estudadas e se tornado cada vez mais claras. A hereditariedade tem um peso determinante, e vários membros de uma família podem ser acometidos pelo problema.

A depressão tem caráter recorrente: após o primeiro episódio depressivo, o risco de novo episódio é de 50%; após o segundo, de 70 a 80%; e, a partir de então, a probabilidade de recorrência aproxima-se de 100%.⁷

O suicídio é a consequência mais trágica da depressão: 8% de mortalidade em pacientes acometidos por depressão que já foram internados devido a risco de suicídio; 4% em pacientes internados com depressão, mas sem risco de suicídio; e 2% em uma combinação de pacientes deprimidos internados ou em atendimento ambulatorial.⁸

No hospital geral, de um a dois terços dos pacientes deprimidos não são detectados e tratados de forma adequada.⁹ Isso ocorre, pelo menos em parte, porque a equipe assistencial focaliza seu trabalho no tratamento das condições físicas agudas. Além disso, pode, também, considerar que os sintomas depressivos são “apropriados” e “compreensíveis” diante da situação do paciente, deixando de fazer o diagnóstico de depressão.

Os profissionais podem, ainda, estar movidos por crenças errôneas a respeito de quem fica deprimido.¹⁰ É preciso lutar contra o preconceito – pessoas que sempre foram dinâmicas, alegres e otimistas também podem ter depressão. Não são apenas os indivíduos mais frágeis que adoecem. Depressão não é tristeza e não se cura apenas com força de vontade.

FREQUÊNCIA

Um levantamento com uma população de 1.464 indivíduos da cidade de São Paulo utilizou critérios diagnósticos da *Classificação internacional de doenças e problemas relacionados à saúde* (CID-10) e demonstrou que a prevalência do episódio depressivo ao longo da vida é de 17% (1 em cada 6 pessoas). Para tanto, utilizou-se um questionário detalhado que possibilitava o diagnóstico de depressão maior (do inglês *major depression*, um quadro clínico mais grave; casos mais leves não foram incluídos).¹¹

Outro estudo avaliou 4.352 pacientes consecutivamente internados em enfermarias clínicas e cirúrgicas do Hospital de Clínicas da Universidade Estadual de Campinas (HC Unicamp) e chegou à prevalência de 14% de depressão (10% em homens; 19% em mulheres).¹² Seis meses após a alta hospitalar, a reavaliação de 50 casos de episódio depressivo revelou que dois terços continuavam deprimidos. Apenas uma minoria (um terço do total) havia recebido tratamento para depressão.¹³

Um estudo realizado no Hospital Universitário da Universidade Federal de Santa Catarina que avaliou pacientes admitidos em enfermarias clínicas revelou associação entre o diagnóstico de depressão e a percepção de maiores níveis de dor, menor qualidade de vida e falta de apoio social.¹⁴ Independentemente de qual desses fatores tenha sido o primeiro ao longo do tempo, os achados demonstram que o indivíduo que está deprimido, durante uma internação em hospital geral, sente-se em piores condições do que outros pacientes sem depressão.

COMORBIDADES NÃO PSIQUIÁTRICAS

A depressão frequentemente se associa a outras doenças graves, não psiquiátricas, bem como a quadros dolorosos.¹⁵ A partir dos estudos pioneiros de Frasure-Smith, no início da década de 1990, sabe-se que a chance de morrer ou de ter novo infarto do miocárdio é três vezes maior quando há depressão.¹⁶ Esses efeitos parecem ser mediados por alterações no eixo hipotálamo-hipófise-suprarrenal, com produção elevada de cortisol, ativação de plaquetas e ruptura de placas ateromatosas. O aumento do tônus simpático e a diminuição da variabilidade da frequência cardíaca são fatores associados à depressão que podem aumentar o risco para o infarto.¹⁷ A American Heart Association recomenda aos cardiologistas a aplicação de *screening* para depressão.¹⁸

Um estudo de Badescu e colaboradores¹⁹ revela que pessoas que sofrem de diabetes têm três vezes mais depressão do que a população em geral, com mais prejuízos nas atividades diárias e na vida social. A depressão implica menos autocuidado, menor adesão ao tratamento e menor controle da glicemia.

Carnes-Vendrell e colaboradores²⁰ referem que, após um acidente vascular cerebral (AVC), os índices de depressão apurados em diversos estudos situam-se entre 11 e 61%. A depressão, nesses casos, associa-se à gravidade e ao grau de incapacidade e comprometimento cognitivo.

NÃO É SÓ TRISTEZA

A depressão é de natureza distinta da tristeza ou do desânimo que sentimos em alguns momentos da vida. O Quadro 15.1 procura diferenciar depressão de tristeza. Em algumas situações, a distinção é difícil, como quando um período de luto se estende ou se agrava além do esperado. A esse respeito, é preciso lembrar que, quando a gravidade e o impacto dos sintomas são consideráveis, deve-se iniciar um antidepressivo, ainda que possamos compreender o que desencadeou a depressão. Em muitas situações para as quais inicialmente recomendaríamos a psicoterapia, a gravidade do quadro clínico leva-nos a decidir pela introdução de um medicamento.

QUADRO 15.1

Algumas características diferenciais entre tristeza e depressão

Característica	Tristeza	Depressão
Duração	Horas a dias	Semanas a meses
Perda afetiva	Presente	Geralmente ausente
Autoestima	Preservada	Muito comprometida
Sentir-se inútil	Ausente	Presente
Desempenho em tarefas cotidianas	Geralmente preservado	Muito comprometido
Ânimo ocasional	Geralmente sim	Nunca
Sintomas corporais	Mínimos	Graves
Retardo psicomotor	Leve ou ausente	Geralmente presente
Ideia de suicídio	Improvável	Comum

Para algumas pessoas, o marcante da depressão não é a tristeza, mas a angustiante sensação de vazio, de falta de sentido e de ausência de sentimentos. A depressão afeta a capacidade de sentir prazer ao fazer coisas que antes eram prazerosas. Esse fenômeno é conhecido pelo termo *anedonia*.

A personalidade é ansiosa e energética; a depressão faz a tonalidade do humor saltar para a irritabilidade. Essa combinação de humor depressivo e irritabilidade é chamada de *disforia*. A pessoa que antes era alegre e positiva vai ficando intolerante, rude ou mesmo mal-educada.

A depressão afeta a capacidade de realizar tarefas que exigem esforço cognitivo, como concentrar-se, memorizar, raciocinar, tomar decisões, etc. Por causa da depressão, a capacidade intelectual decai, bloqueando a capacidade de iniciar ações e de adaptar o comportamento a novos estímulos e situações. A pessoa se sente indecisa, sobrecarregada e tende a adiar tudo o que puder. A vivência é de um bloqueio mental.

Embora algumas pessoas consigam esconder seu sofrimento dentro de uma espécie de couraça (com esforço, cuidam-se, batalham, não parecem tristes), uma avaliação clínica cuidadosa geralmente revela vários sintomas da doença.

Em adolescentes, a depressão pode vir com retraimento social, crises de raiva e mau desempenho escolar; em idosos, com tendência ao isolamento e à diminuição da vontade de interagir com os familiares, sensação de peso e dores corporais, pensamentos sobre morte, etc. De modo geral, homens têm maior dificuldade do que mulheres para admitir que não se sentem bem emocionalmente e que necessitam de ajuda. Eles podem se tornar mais calados, mal-humorados e irritadiços e mais propensos a apresentar crises de raiva quando contrariados.

CLASSIFICAÇÃO

A síndrome depressiva associada a outras condições clínicas pode ocorrer de diversas formas, descritas a seguir.

Reação de ajustamento com humor depressivo

As reações de ajustamento podem ser tomadas como uma síndrome parcial de um transtorno específico do humor a meio caminho entre o normal e um transtorno depressivo maior. De modo semelhante ao observado em atenção primária, o padrão mais comum de sintomas é de natureza indiferenciada, compreendendo uma combinação de preocupações excessivas, ansiedade, depressão e insônia. Esses quadros geralmente melhoram com o apoio psicológico e a boa comunicação. Psicotrópicos raramente são necessários.

Depressão secundária

É aquela que ocorre devido a alterações fisiopatológicas de uma condição clínica. O transtorno depressivo apresenta-se de forma independente do significado ou do impacto do adoecer. Tomando como exemplo o caso de um AVC, considera-se secundária a depressão provocada pela lesão em circuitos neuronais envolvidos no controle do humor. As doenças que mais frequentemente causam depressão encontram-se no Quadro 15.2.

QUADRO 15.2

Doenças e medicamentos que podem causar depressão

Doenças neurológicas

- Doença cerebrovascular
- Tumores frontais
- Epilepsia (principalmente de lobo temporal)
- Doença de Huntington
- Doença de Parkinson
- Doença de Alzheimer
- Esclerose múltipla
- Paralisia supranuclear progressiva
- Hemorragia subaracnóidea

Endocrinopatias

- Hiper e hipotireoidismo
- Síndrome de Cushing
- Diabetes melito
- Doença de Addison
- Hiperparatireoidismo
- Hipopituitarismo

Neoplasias

- Carcinoma de pâncreas
- Carcinoma de pulmão
- Tumores do sistema nervoso central

Doenças infecciosas

- Aids
- Encefalite

- Gripe
- Hepatite
- Mononucleose
- Pneumonia viral
- Sífilis terciária

Outras doenças

- Alcoolismo
- Anemia
- Deficiências: folato e vitaminas B2, B12 e D
- Doença de Wilson
- Dor crônica
- Infarto agudo do miocárdio
- Insuficiência hepática
- Insuficiência renal crônica
- Intoxicação por metais pesados
- Lúpus eritematoso sistêmico

Medicamentos

- Ácido nalidíxico
- Anfetamínicos, cocaína (abstinência)
- Anfotericina
- Anti-hipertensivos (reserpina, metildopa, clonidina, nifedipina, hidralazina, prazosina, diuréticos)
- Anti-inflamatórios não esteroides
- Antipsicóticos
- Benzodiazepínicos
- Betabloqueadores (especialmente propranolol)
- Cimetidina
- Cinarizina
- Contraceptivos orais
- Corticosteroides
- Desequilíbrio eletrolítico
- Digitálicos
- Efavirenz
- Flunarizina
- Interferon
- Isoniazida
- Levodopa
- Metoclopramida
- Metronidazol
- Ranitidina
- Vareniclina (usada para auxiliar na cessação de tabagismo)
- Vimblastina
- Vincristina
- Zidovudina

A exemplo do que pode ocorrer com os transtornos depressivos, quadros de mania podem ser causados por doenças orgânicas (Quadro 15.3), notadamente em idosos. Uma causa frequente para síndromes maníacas ou hipomaníacas em pacientes clínicos é o uso de doses de prednisona acima de 40 mg/dia.²¹

QUADRO 15.3

Doenças e medicamentos que podem causar episódio de mania

Doenças neurológicas

- Epilepsia (principalmente de lobo temporal esquerdo)
- Traumatismo craniano
- Esclerose múltipla
- AVC (principalmente de hemisfério direito e tálamo)

Endocrinopatias

- Hipertireoidismo
- Síndrome de Cushing
- Doença de Addison

Neoplasias

- Gliomas
- Meningiomas
- Metástases talâmicas

Doenças infecciosas

- Criptococose
- Encefalite
- Gripe

Outras doenças

- Alcoolismo
- Anemia
- Doenças que requeiram hemodiálise
- Encefalopatia hepática em fase inicial
- Doença de Wilson

Medicamentos

- Álcool
- Alprazolam
- Anfetaminas
- Captopril
- Corticosteroides
- Alucinógenos
- Isoniazida
- Levodopa
- Simpaticomiméticos
- Sífilis terciária

Depressão induzida por medicamentos

Reserpina, corticoides e interferon são os medicamentos mais frequentemente associados a manifestações depressivas. Essas substâncias, listadas no Quadro 15.2, interferem direta ou indiretamente na neurotransmissão e na fisiologia neuronal, produzindo os sintomas depressivos.

Episódio depressivo

Um episódio depressivo maior pode ser desencadeado ou agravado pela condição médica. Nessa situação, não se tem, unicamente, uma reação de ajustamento à doença, nem a sintomatologia depressiva é decorrente de forma direta das alterações fisiopatológicas da condição médica. Esta última apenas desencadeou ou agravou um transtorno depressivo do paciente. O estresse, de modo inespecífico, contribui para a manifestação do transtorno depressivo preexistente ou

latente. Deve-se lembrar, ainda, a possibilidade de se tratar de uma fase depressiva do transtorno bipolar.

Condição médica desencadeada ou agravada por transtorno depressivo

A depressão, isolada ou em conjunto com outros fatores de risco (hipercolesterolemia, diabetes, hipertensão arterial, tabagismo, obesidade, sedentarismo, etc.), pode precipitar a ocorrência do infarto agudo do miocárdio, por exemplo.

É preciso reconhecer a difícil delimitação dessas categorias. A depressão e a condição médica também podem ocorrer concomitantemente, sem que exista, de acordo com o julgamento clínico, uma associação entre ambas.

DIAGNÓSTICO

Elaborado segundo critérios operacionais, o diagnóstico de depressão não é passível de comprovação por meio de exames de imagem ou de testes laboratoriais. Isso, para alguns pacientes e familiares, é difícil de ser aceito.

O Quadro 15.4 traz os critérios diagnósticos para depressão maior segundo o *Manual diagnóstico e estatístico de transtornos mentais* (DSM-5),²² acrescidos de algumas perguntas, por nós sugeridas, que podem ser formuladas ao paciente. Fazer o diagnóstico de depressão em pacientes clínicos e cirúrgicos pode ser mais difícil. Há sempre a dúvida se os sintomas que chamam a atenção são devidos à condição clínica em si ou são indicativos de algo a mais, ou seja, de uma depressão. Na tentativa de facilitar o raciocínio clínico, elaborou-se o Quadro 15.5, com lembretes e sugestões de perguntas que auxiliam no diagnóstico diferencial.

QUADRO 15.4

Critérios diagnósticos do DSM-5²² para depressão e algumas perguntas exploratórias

- Cinco ou mais dos sintomas a seguir presentes de forma intensa e duradoura por, no mínimo, duas semanas.
- Pelo menos um desses sintomas é humor deprimido ou perda de interesse/prazer.

Sintomas	Perguntas exploratórias
Humor deprimido	<i>Você se sente mais triste do que de costume? Tem a sensação de que a vida perdeu o sentido, o colorido? Acha graça nas coisas, consegue sorrir se lhe contam algo engraçado? Está mais emotivo? Tem chorado mais ou sentido como se fosse chorar? Alguma pessoa próxima comentou que você está diferente? Você se sente mais irritado, com o pavio curto?</i>
Anedonia (diminuição do interesse ou prazer em atividades antes prazerosas)	<i>O que você costuma fazer com prazer quando tem um tempo para si mesmo? Poderia me dar exemplos de coisas de que sempre gostou de fazer? Tem feito isso ultimamente e sente o mesmo prazer de antes? Você se anima com as coisas boas que estão por acontecer? Tem gostado de sair, ver TV, ler, ouvir música...? Tem se interessado pelas coisas que estão acontecendo? Tem encontrado pessoas de quem gosta? Acha graça nas conversas? Tem reparado mudanças no seu interesse sexual?</i>
Diminuição ou aumento do peso/apetite	<i>Essa perda/esse ganho de peso é habitual, ou você nunca esteve com o peso atual?</i>
Insônia ou hipersonia	<i>Você tem acordado mais cedo do que de costume e não conseguido mais pegar no sono?</i>
Retardo psicomotor ou agitação	<i>Você se sente mais lento? Tem dificuldade para se movimentar? Sente o corpo pesado? Está inquieto? Não conseguiu assistir a um filme inteiro/um jogo de futebol por não conseguir permanecer sentado (e atento)?</i>
Fadiga ou perda da energia	<i>Está mais difícil fazer as coisas que fazia antes? Dê um exemplo. Sente que lhe falta energia para fazer as coisas que sempre o animaram?</i>
Sentimentos de inutilidade ou culpa	<i>Você se sente uma pessoa útil (no trabalho, para alguém...)? Tem pensado muito em erros que cometeu? Tem ideias negativas que não lhe saem da cabeça?</i>
Dificuldade para pensar, concentrar-se, tomar decisões	<i>Está mais difícil pensar, concentrar-se...? Sente-se seguro quando tem de decidir algo? Tem conseguido tomar decisões?</i>
Pensamentos de morte, incluindo ideação suicida	<i>Pensa que seria melhor estar morto? Pensa em tirar a própria vida? O que esse pensamento provoca em você (mal-estar, indiferença, alívio)? Esses pensamentos são passageiros ou duradouros? Você consegue afastar esses pensamentos de suicídio?</i>

Tem planejado como poderia se matar?

- Os sintomas causam sofrimento e dificuldades significativas em várias áreas da vida, como interpessoal, social, profissional, etc.
- O quadro clínico não é atribuível a efeitos de substâncias ou de outra doença não psiquiátrica.
- O quadro clínico não é mais bem explicado pela presença de certos transtornos psicóticos.

Observação: Além dos sintomas constantes no DSM-5, outros costumam estar presentes, como irritabilidade, intolerância, aumento da emotividade, ruminações excessivas, sensação de inadequação, choro fácil, explosões de raiva, sensação de vazio, diminuição da libido, falta de iniciativa, ruminação de pensamentos negativos, pessimismo, diminuição de cuidados com a higiene e a aparência física, retração social, desesperança, ritmo circadiano com piora de sintomas no período da manhã e dores corporais difusas.

QUADRO 15.5

Auxílio ao diagnóstico de depressão quando há outras doenças não psiquiátricas

1. Avaliar o nível de consciência

Se o nível de consciência se altera ao longo do dia, se há, concomitantemente, confusão mental e desorientação, deve-se pensar em *delirium*. Um paciente com *delirium* hipoativo que se mantém passivo e calado pode ser tomado erroneamente como “deprimido”. Isso também pode ocorrer quando há perda de espontaneidade (demência, síndrome do lobo frontal).

2. Verificar a presença de sintomas cognitivos da depressão (sentimento de culpa, prejuízo da autoimagem, pessimismo, ideação suicida)

- O senhor se culpa muito por coisas do passado? E por sua doença?
- Como acredita que as pessoas o veem? O senhor se vê dessa maneira?
- O senhor se anima com a alta hospitalar? Tem esperança de que as coisas vão melhorar?
- Quais são os seus planos para o futuro?
- Sente que a vida vale a pena? Tem pensado em morte? De que maneira?

3. Pesquisar existência de anedonia

- Consegue se distrair com a TV (lendo, ouvindo música, etc.)? Anima-se com as visitas? Prefere se isolar?
- Quando estava bem (antes de se internar), o que mais gostava de comer? Agora, imagine-se quando tiver alta do hospital. Gostaria de comer um bom prato de...?
- O que sempre gostou de fazer na vida? Agora, imagine-se quando não estiver mais internado. Gostaria de... (repetir o relatado pelo paciente)?
- Observe e pergunte para a enfermagem, ou um colega de quarto, se o paciente se anima com visitas, com a aparência antes de recebê-las, se gosta de conversar com quem lhe dirige a palavra.

4. Afetividade

Lembre-se: não procure só por tristeza. Pergunte sobre vontade de chorar, de não ver ninguém; sobre sensação de vazio; sobre não se importar com o que vai acontecer ou deixar de acontecer; sobre intolerância e irritabilidade. Se a principal alteração de humor for apatia, em vez de depressão, a existência de transtorno orgânico do humor é mais provável.

5. Sintomas somáticos

Se estiverem temporalmente relacionados a humor depressivo e/ou anedonia e em intensidade desproporcional ao esperado em dada condição física, ajudam no diagnóstico.

6. Antecedentes pessoais e familiares de depressão

São frequentes no transtorno do humor unipolar e mais frequentes ainda no bipolar.

Exames laboratoriais complementares devem ser solicitados para o diagnóstico diferencial, de acordo com dados da anamnese e do exame do paciente. A atenção a esse aspecto deve ser redobrada em mulheres a partir da meia-idade (a considerável frequência de hipotireoidismo requer dosagens de TSH e T4 livre) e em idosos (vitamina B12, ácido fólico). Recomendam-se, como exames gerais, dosagem de eletrólitos, glicemia, hemograma e vitamina D,^{23,24} e, em casos especiais, também se solicitam imagem cerebral (de preferência ressonância magnética) e exames de funções renal e hepática.

Diagnóstico em situações de comorbidade

No hospital geral, o sofrimento gerado por dor, ameaça de morte (real ou percebida), incapacidade funcional ou simplesmente pela internação já é suficiente para causar a desmoralização do sujeito, o que se assemelha aos quadros depressivos.

Sintomas como insônia, fadiga, perda de peso e perda da libido são frequentes, mesmo em pacientes que não se encontram deprimidos, melhorando espontaneamente à medida que o indivíduo se adapta a sua condição física ou a vê melhorar.⁵

Entretanto, esses sintomas corroboram o diagnóstico de depressão quando ocorrem em excesso em relação ao esperado para a condição física e seu tratamento e surgem associados temporalmente aos sintomas cognitivos e afetivos da depressão (humor depressivo, anedonia). Perda do interesse na alta hospitalar e nas pessoas que vêm para a visita, pessimismo (desânimo), indecisão, irritabilidade, sensação de fracasso e culpa, fadiga e anedonia são importantes discriminantes dos casos de depressão.²⁵

A anedonia pode ser difícil de ser avaliada no hospital geral, já que os pacientes internados têm múltiplas incapacitações que impedem atividades que antes eram prazerosas. Assim, a presença desse sintoma pode ser investigada por meio da observação e de perguntas que auxiliem a detectar a perda de interesse e prazer no autocuidado nas conversas com companheiros de quarto e nas visitas de familiares. O paciente se imagina tendo prazer no futuro? Quando não deprimidos, os pacientes conseguem manifestar algum interesse, planos para o futuro, bem como imaginar que, se pudessem, teriam prazer em trabalhar, alimentar-se, ter vida sexual?

Na avaliação dos sintomas depressivos, também é muito importante o conhecimento da doença física de base. Há inúmeros exemplos de sutilezas que cercam o diagnóstico de depressão no paciente clínico, para os quais temos de estar atentos, como, por exemplo:

- Sintomas como baixa energia, insônia, ansiedade e irritabilidade são frequentes em pacientes com dor e sem depressão, mas culpa e isolamento, não.
- Sempre verifique se a dor está sendo tratada adequadamente. Dor persistente e não controlada anda de mãos dadas com sintomas depressivos.
- Fadiga é um sintoma extremamente frequente em pacientes com câncer, diabetes, doença renal terminal, artrite reumatoide e esclerose múltipla.
- O retardo psicomotor (lentificação dos movimentos observada pelo examinador) é incomum no paciente clínico, exceto nos pacientes com hipotireoidismo e doença de Parkinson.

Diferenciar depressão de déficits cognitivos, incluindo síndromes demenciais, é uma tarefa difícil, tanto em idosos quanto em alguns pacientes acometidos por HIV. Depressão em idosos comumente cursa com comprometimento cognitivo. Entretanto, às vezes, a demência se inicia com sintomas depressivos para, posteriormente, apresentar sintomas de disfunção cognitiva. O Quadro 15.6 resume algumas informações que podem auxiliar na discriminação entre demência e depressão. Mantenha em mente que, em idosos, quadros depressivos podem evoluir para demência.

QUADRO 15.6

Diferenciação entre demência e depressão no paciente idoso

Características clínicas	Depressão	Demência
Início	Relativamente rápido	Insidioso
Época de início	Pode ser precisada	Raramente
Déficit cognitivo	Flutuante	Constante
Queixas cognitivas	Enfatizadas, detalhadas	Minimizadas, vagas
Perda de memória recente x remota	Equivalente	Recente > remota
Manifestação de sofrimento	Sim	Geralmente não
Declínio da sociabilidade	Precoce	Tardio
Humor	Deprimido	Normal ou embotado
Labilidade emocional	Ausente	Presente
Autoimagem	Negativa	Não afetada
Esforço para realizar tarefas	Pequeno	Grande
Resposta do tipo “não sei”	Frequente	Rara

É importante lembrar que a avaliação do risco de suicídio é obrigatória em pacientes deprimidos. Um estudo realizado no HC Unicamp mostrou que o pensamento de pôr fim à vida estava presente em 5% dos pacientes internados e em 22% dos que estavam deprimidos.^{26,27} O Capítulo 16 focaliza o comportamento suicida no hospital geral, abordando questões referentes à avaliação do risco de suicídio e ao manejo dos pacientes.

Escala também podem auxiliar no rastreamento ou na mensuração da gravidade da depressão (Quadro 15.7).

QUADRO 15.7

Escalas de depressão

Escalas podem ajudar?

Sintomas corporais ou “vegetativos” da depressão encontram-se presentes na maioria das escalas de ansiedade e depressão, como é o caso da Escala de Depressão de Beck. Em pesquisas epidemiológicas, tal fato pode superestimar a frequência dos transtornos do humor por conta de pacientes que apresentam sintomas ocasionados pela patologia física, sem terem algum transtorno mental. Contudo, o referido instrumento já se mostrou útil para detectar depressão em pacientes clínicos.²⁸

A Escala Hospitalar de Ansiedade e Depressão (HAD), de autopreenchimento, contém 7 itens para ansiedade e 7 para depressão.²⁹ Não figuram itens como insônia, fadiga, taquicardia, anorexia, perda de peso, etc., que podem, também, ser sintomas de doenças físicas. A subescala de depressão centra-se na anedonia. A HAD já está validada em nosso meio e tem sido utilizada tanto para rastreamento diagnóstico quanto para medir a gravidade da ansiedade e da depressão.^{30,31} Mais informações sobre essa escala encontram-se no Capítulo 9.

Escala podem ajudar na avaliação de possível depressão. A utilização de instrumentos de *screening* permite, de modo rápido, prático e confiável, sensibilizar o paciente e o médico para a presença de sintomas depressivos, os quais, de outro modo, não seriam valorizados. Ao considerar a pontuação nessas escalas, o profissional tem o caminho aberto e facilitado para realizar sua avaliação e confirmar ou não o diagnóstico.³²

FASES DO TRATAMENTO

Diversos estudos têm confirmado a importância do tratamento combinado (medicação e abordagens psicoterapêuticas) na depressão. As abordagens psicológicas podem ser a opção exclusiva em casos mais leves, notadamente nos transtornos reativos. Em relação aos pacientes internados, vale dizer que não são adequadas as técnicas psicoterápicas convencionais. Nesse contexto, é mais importante ter uma “atitude terapêutica” e utilizar estratégias específicas.³³ Para aprofundamento, ver Capítulo 26, sobre abordagem psicodinâmica em situações de crise.

Aqui, enfatizamos aspectos relacionados ao tratamento farmacológico de pacientes clínicos que apresentam depressão grave ou moderada. Um recurso valioso de tratamento de quadros mais graves é a eletroconvulsoterapia (ECT),^[NT] abordada no Capítulo 12. Os quadros clínicos para os quais a ECT deve ser considerada tratamento de primeira escolha são apresentados no Quadro 15.8.

QUADRO 15.8

Condições clínicas para as quais a ECT deve ser considerada como primeira escolha

- Depressão com sintomas psicóticos
- Depressão com sintomas de estupor ou catatonia
- Pacientes com risco grave de suicídio
- Pacientes que recusam alimentação e cujo estado nutricional esteja gravemente debilitado
- Pacientes grávidas que necessitam de resposta terapêutica rápida
- Pacientes que responderam previamente à ECT de forma marcante
- Preferência do paciente

Outros tratamentos biológicos, como a estimulação magnética transcraniana, a estimulação do nervo vago e a estimulação cerebral profunda, têm caráter experimental, pois ainda aguardam padronização de procedimentos, bem como evidências científicas quanto a eventuais benefícios e riscos. Por essa razão, fogem do escopo deste capítulo.

O tratamento farmacológico da depressão pode ser dividido, didaticamente, em fases, como se resume no Quadro 15.9. Enfatizamos a importância de atentar para as principais tarefas do médico e as sutilezas de cada momento do tratamento.

QUADRO 15.9

Fases do tratamento da depressão

Inicial Período de latência	Aguda Período de resposta	Manutenção Prevenção de recaída	Prevenção Prevenção de recorrência
1-2 semanas	2 semanas a 2-3 meses	6 meses (mínimo) após melhora	Vários anos (indeterminado)
Contornar efeitos colaterais e detectar ideação suicida.	Ajustes para alcançar remissão, não só melhora parcial.	Interrupção eleva risco de recaída – imbuir paciente dessa ideia.	Em casos especiais, utilizar antidepressivos continuamente.
Doses menores (25-50%), por 4-6 dias, diminuem efeitos colaterais (há pessoas com menor tolerância).	60-70% melhoram com a primeira medicação em dose plena (remissão é menor: 33%).	Após melhora de casos graves ou prolongados, manter o tratamento por, no mínimo, 12 meses.	Após dois episódios, há 80% de chance para um terceiro. Após três, é quase certo que haverá novos episódios mais graves e mais longos.

É preferível ingerir medicação com alimentos para diminuir a náusea.	Alguns melhoram antes de duas semanas. A maioria, entre 2 e 4 semanas.	Devem ser mantidas medicação e dose (não diminuir) da fase aguda.	O risco é maior em depressão de início tardio (a partir dos 50 anos ou a partir dos 40, já com uma recorrência).
Medicações mais ativadoras de manhã (p. ex., fluoxetina, venlafaxina). As mais sedativas à noite (p. ex., mirtazapina, trazodona).	Se houver melhora parcial, sem remissão: aumentar dose até o máximo.	Pode ocorrer diminuição do efeito antidepressivo: ajustar tratamento.	Manter o medicamento e a dose que foram eficazes nas fases anteriores.
Pode haver sonolência com drogas que, em geral, são ativadoras – transferir medicamento para a noite.	Se isso persistir: potencialização (farmacológica e não farmacológica) ou combinação de antidepressivos.	TÉRMINO: Interrupção abrupta pode causar sintomas de abstinência após 1-4 dias.	Ainda não há informações sobre quando interromper a prevenção com segurança. Por ora, é melhor usar antidepressivo de modo contínuo, ao longo da vida.
Às vezes, no início, é necessário incluir medicação para insônia.	Ausência de resposta após 3 semanas em dose máxima: mudar medicação.	Sintomas diminuem após uma semana, mas podem durar mais.	
Ideação suicida provocada pela medicação é rara, mas perigosa. Manter contato telefônico para monitorar e incentivar adesão.	Melhor mudar para outra classe de antidepressivo (para a mesma classe também pode funcionar). Atentar para períodos de transição entre uma e outra droga (p. ex., reação serotoninérgica)	Diminuir dose paulatinamente ao longo de 7-10 dias (20-30 dias no caso de tricíclicos, venlafaxina e paroxetina).	

É crucial a aliança terapêutica, uma vez que o início da ação dos medicamentos pode demorar de 1 a 3 semanas, os efeitos adversos, no início, podem pesar mais do que a melhora dos sintomas depressivos, e tanto pacientes quanto familiares podem ter concepções e expectativas equivocadas em relação à depressão e ao seu tratamento.

Muitas pessoas, vendo-se livres dos sintomas da depressão, resolvem interromper a medicação; algumas para “fazer um teste”, outras, com receio de “ficarem dependentes”, ou mesmo por enfrentarem efeitos adversos (p. ex., aumento de peso, disfunção sexual, certa anestesia emocional). A interrupção precoce do tratamento implica risco aumentado de recaída, em torno de 50 a 80%, que é o dobro do observado entre os pacientes que mantêm a medicação.³⁵ Isso deve ser objeto de informação a ser reforçado nas consultas.

MEDICAMENTOS ANTIDEPRESSIVOS

Até o início da década de 1990, os antidepressivos tricíclicos (ADTs) e os inibidores da monoaminoxidase (IMAOs) foram o tratamento-padrão da depressão. A partir de então, evoluiu-se das descobertas ao acaso à síntese calculada de drogas mais específicas. Foi esse o caso dos inibidores seletivos da recaptação de serotonina (ISRSs; fluoxetina sintetizada em 1987), dos inibidores da recaptação de serotonina e noradrenalina (IRSNs) e de outras drogas mais recentes (Tab. 15.1).

Tabela 15.1

Principais neurotransmissores envolvidos no efeito antidepressivo e faixa terapêutica de algumas drogas

Antidepressivo	Receptores			Faixa terapêutica habitual (mg/dia) *
	NA	5-HT	DA	
ADTs	+++	++	0	75-200
Amitriptilina	+	+++	+/-	75-250
Clomipramina	+	++	0	75-250
Imipramina	++	+/-	0	25-100
Nortriptilina				
IMAOs	++	++	++	20-60
Tranilcipromina				
ISRSs	0	++	0	20-60
Citalopram	0	++	0	10-20
Escitalopram	0	++	0	20-60
Fluoxetina	0	++	0	50-200
Fluvoxamina	0	+++	0	20-60
Paroxetina	0	++	0	50-200
Sertralina				
IRSNs	++	++	0	50-100
Desvenlafaxina	++	++	0	60-120
Duloxetina	++	++	+/-	75-225
Venlafaxina				
Outros	+/-	0	++	150-300
Bupropiona	+	++	0	15-45
Mirtazapina	0	++	0	50-300
Trazodona	++	++	+	10-20
Vortioxetina**				

* Doses devem ser reduzidas em idosos e em certas condições clínicas.

** O efeito é indireto em receptores noradrenérgicos e dopaminérgicos (ver texto).

NA = noradrenalina; 5-HT = serotonina; DA = dopamina.

0 = sem efeito; + a +++ = efeito crescente; +/- = pouco efeito.

A escolha de um antidepressivo é balizada pelos seguintes fatores: quadro clínico (segundo o predomínio de alguns sintomas, como ansiedade, insônia, apatia), condições do paciente que contraindiquem determinada droga, efeitos colaterais (entre os principais, sedação, hipotensão, ganho de peso, cardiotoxicidade), presença de determinadas doenças físicas, certas características do fármaco (farmacocinética, interações medicamentosas) e custo do tratamento.³⁶

A afinidade dos antidepressivos por diferentes neurorreceptores define, além do suposto mecanismo de ação, um padrão de efeitos adversos (Quadro 15.10). Pelo menos 10% dos pacientes abandonam o tratamento em decorrência desses incômodos. A Tabela 15.2 relaciona os

principais efeitos adversos de alguns antidepressivos, figurando a fluoxetina como protótipo dos ISRSs.

QUADRO 15.10

Efeitos adversos frequentes, segundo neurotransmissão envolvida

Efeitos anti-histamínicos	Sonolência, ganho de peso, fadiga, tontura, hipotensão
Efeitos anticolinérgicos	Boca seca, obstipação, retenção urinária, taquicardia, visão turva, aumento da pressão ocular, ganho de peso, disfunção sexual, alucinações, confusão mental
Efeitos antiadrenérgicos	Hipotensão arterial, taquicardia, tontura, tremores, congestão nasal, retardo da ejaculação, disfunção erétil
Efeitos serotoninérgicos	Irritabilidade, agitação, insônia, cefaleia, fadiga, náusea, diarreia, insônia, disfunção sexual

Tabela 15.2

Principais efeitos adversos dos antidepressivos

Antidepressivo	Anticolinérgico	Cardíaco	Náuseas	Sedação	Disfunção sexual	Hipotensão	Ganho de peso
Tricíclicos							
Amitriptilina	3	3	2	3	2	3	3
Clomipramina	3	2	2	2	3	2	2
Imipramina	2	2	2	1	2	2	1
Nortriptilina	2	1	2	1	2	1	1
IMAOs							
Tranilcipromina	1	1	2	1	1	2	1
ISRSs							
Citalopram	0	*	3	0	2	0	1
Escitalopram	0	*	2	0	2	0	1
Fluoxetina	0	0	2	0	2	0	0
Fluvoxamina	1	0	3	1	2	0	1
Paroxetina	1	0	2	0	3	0	2
Sertralina	0	0	2	0	2	0	0
IRSNs							
Desvenlafaxina	0	2	2	1	1	0	0
Duloxetina	0	0	1	0	0	0	0
Venlafaxina	0	2	2	1	2	0	1
Outros							
Bupropiona	1	0	1	0	0**	0	0
Mirtazapina	0	0	0	2	1	1	3
Trazodona	1	1	3	2	1	2	1
Vortioxetina	0	0	2	0	0***	0	0

* Ver texto em relação a risco de aumento do intervalo QTc em doses elevadas em idosos e em indivíduos predispostos.

** Risco aumentado de priapismo.

*** Em doses de 20 mg, a disfunção sexual pode ser maior do que com placebo, mas ainda assim menor do que com os outros ISRSs e IRSNs.

Outros efeitos adversos menos frequentes dos antidepressivos devem ser lembrados, como, por exemplo, diminuição do limiar convulsivo, mioclonias, sintomas extrapiramidais, hiponatremia, erupções exantemosas, ganho de peso, hiperprolactinemia e síndrome serotoninérgica central.

Inibidores seletivos da recaptação de serotonina (ISRSs)

Os ISRSs são a primeira linha de tratamento para a depressão. A principal vantagem dos ISRSs em relação aos ADTs e aos IMAOs é seu perfil farmacodinâmico mais específico, o que resulta em menos abandono de tratamento por efeitos colaterais. Entre os vários receptores de serotonina, a 5-hidroxitriptamina 1A (5-HT_{1A}) parece o mais relacionado aos efeitos antidepressivos dos ISRSs. O estímulo de outros receptores serotoninérgicos ocasiona alguns dos efeitos colaterais dessa classe de antidepressivos.

Os ISRSs têm janela terapêutica ampla, por isso são muito menos perigosos que os ADTs em casos de ingestão excessiva. A meia-vida plasmática dos ISRSs fica em torno de 15 a 36 horas. No entanto, a fluoxetina é uma exceção, pois seu metabólito – a norfluoxetina – tem meia-vida plasmática de 7 a 15 dias. Isso deve ser levado em conta na hora de prescrever. Entre a interrupção da fluoxetina e o início de um novo antidepressivo deve haver pelo menos duas semanas. Para os outros ISRSs, basta uma semana.

Os efeitos adversos mais comuns costumam ser leves, como náusea, fezes amolecidas, insônia e cefaleia. Ganho de peso e disfunção sexual também podem ocorrer. Esta última aparece em 50 a 80% dos pacientes e é mais pronunciada com a paroxetina.

Alguns pacientes podem se queixar de ansiedade, inquietude, sensação de cabeça vazia, tremores, mais raramente acatisia. Esses sintomas devem-se à hiperestimulação serotoninérgica na substância negra, levando à redução da liberação de dopamina no núcleo estriado. Tais efeitos colaterais não geram consequências médicas graves e, geralmente, são passageiros. No entanto, podem ser bastante desconfortáveis e levar ao abandono do tratamento. Recomenda-se iniciar com doses menores até que o paciente se adapte.

De modo geral, os ISRSs não se associam a transtornos na condução cardíaca, hipotensão ortostática, sedação, retenção urinária ou prejuízo da memória. Há risco de aumento do intervalo QT com o uso de citalopram em doses superiores a 40 mg/dia (20 mg/dia para idosos ou pacientes com insuficiência hepática). O cuidado estende-se para o S-isômero dessa droga, o escitalopram, que não deve ultrapassar 20 mg/dia, em adultos, e 10 mg/dia, em idosos.³⁷

Um ponto importante em relação aos ISRSs é sua ação inibitória sobre as enzimas do citocromo P450. As principais enzimas afetadas são: 2D6, 3A4, 1A2 e 2C19. Esse sistema enzimático é encontrado, sobretudo, nos hepatócitos (mitocôndrias e retículo endoplasmático). Muitas drogas utilizadas em medicina são metabolizadas por esse sistema, notadamente pelas enzimas 3A4 e 2D6. Os ISRSs podem inibir, mediante mecanismo de competição, várias dessas enzimas. Em consequência, a fluoxetina, por exemplo, pode elevar até três vezes o nível plasmático de um ADT. A situação complica-se com o polimorfismo genético, observado em relação às enzimas 2D6 e 2C19, o que pode agravar a eliminação de drogas e ocasionar intoxicações.

A codeína necessita se transformar em morfina para exercer seu efeito analgésico, o que ocorre por meio da enzima 2D6. Portanto, substâncias que inibem a 2D6 (p. ex., fluoxetina, paroxetina e bupropiona) prejudicam o efeito analgésico dessa substância.³⁸ Da mesma forma, a inibição da enzima 2D6 pela paroxetina administrada concomitantemente com o tamoxifeno

levou à redução do metabólito ativo dessa substância e reduziu sua eficácia em prevenir a recidiva do câncer de mama.³⁹ Para mais informações, veja a seção Câncer do Capítulo 24.

Os ISRSs com meia-vida mais curta são mais apropriados para o uso em várias condições clínicas, de acordo com o que é detalhado no Capítulo 24. Em geral, a sertralina, o citalopram e o escitalopram apresentam perfil mais favorável. Já a paroxetina e a fluvoxamina aumentam a concentração plasmática de hipoglicemiantes orais, bem como da varfarina (anticoagulante). Diabéticos podem necessitar diminuição da dose de insulina se forem utilizar fluoxetina.

A interrupção de um ISRS, notadamente da paroxetina, pode causar sintomas desagradáveis, dentro de 24 a 36 horas, que duram por volta de 10 dias. Esses são os períodos mais frequentes, uma vez que o início do quadro pode ser tardio – mesmo após redução paulatina de dose – e durar mais tempo. Os sintomas mais comuns são mal-estar, ansiedade, insônia, tontura, parestesias, sensação de um tremor interno, palpitações, náusea e diarreia, podendo chegar a ataques de pânico, arritmias cardíacas e *delirium*.⁴⁰ Esse quadro também se observa na interrupção da clomipramina (um ADT) e da venlafaxina (um IRSN). Recomenda-se, portanto, a diminuição lenta dessas drogas.

Inibidores da recaptação de serotonina e noradrenalina (IRSNs)

Esses antidepressivos inibem a recaptação da serotonina e da noradrenalina e, em menor extensão, da dopamina. Apresentam potencial de ação antidepressiva maior do que a dos ISRSs e equivalente à dos ADTs, porém, com menos efeitos colaterais.⁴¹ A exemplo dos ADTs, também são usados no controle da dor neuropática.

A venlafaxina é aprovada pela US Food and Drug Administration (FDA) para o tratamento do transtorno de ansiedade generalizada, além da depressão. Sua meia-vida plasmática é de 15 a 21 horas, na formulação de liberação controlada. É inibidora discreta da enzima hepática 2D6. A forma de liberação controlada produz poucos efeitos colaterais, os mais comuns sendo náusea, insônia e disfunção sexual. Pode elevar a pressão arterial sistólica, fenômeno que se incrementa com o aumento de doses.

A duloxetina tem meia-vida plasmática entre 10 e 15 horas. Os principais metabólitos não são farmacologicamente ativos. É um inibidor moderado da 2D6, por isso não deve ser utilizada simultaneamente com outras drogas metabolizadas por essa enzima. Náusea é o efeito colateral mais comum.

Essas drogas, notadamente a venlafaxina, devem ser retiradas lentamente, pois a interrupção abrupta pode ocasionar sintomas de abstinência (mal-estar, parestesias, inquietude, náusea, cefaleia e tontura).

Antidepressivos tricíclicos (ADTs)

Além de aumentarem a disponibilidade de catecolaminas nas sinapses, esses antidepressivos atuam em diversos sistemas de neurotransmissão e interagem com várias drogas sedativas, anti-histamínicas e anticolinérgicas.

A cardiotoxicidade representa o maior perigo que acompanha a utilização dos ADTs. A inibição da ATPase e da bomba Na/K leva à estabilização da membrana celular. Pode haver aumento da frequência cardíaca, achatamento da onda T, prolongamento do intervalo PR e aumento do complexo QRS. Em razão desses efeitos, os ADTs podem ser fatais na intoxicação (ver Cap. 24).

Os ADTs são contraindicados no infarto agudo do miocárdio, no bloqueio de ramo e em certas arritmias cardíacas, na insuficiência hepática grave e na gravidez. Precauções especiais são requeridas em caso de prostatismo, glaucoma de ângulo estreito, doenças cardiovasculares, epilepsia, diabetes melito, hipertireoidismo, hipertensão arterial, transtornos hepáticos, psicoses e casos de ideação suicida.

Em pacientes idosos, há maior risco do surgimento de quadro confusional devido à síndrome anticolinérgica central, na qual alterações do nível de consciência são acompanhadas de alucinações, delírios, agitação, hipertensão arterial e outros sintomas anticolinérgicos. A sedação (efeito anti-histamínico) pode ser até desejável em pacientes deprimidos que apresentam ansiedade e inquietude. No entanto, pode também significar piora do desempenho cognitivo e acidentes. Quedas e fraturas também são frequentes em consequência da sedação e da hipotensão ortostática (bloqueio alfa-adrenérgico). Entre os ADTs, a nortriptilina é a que menos causa hipotensão ortostática.⁴¹

Inibidores da monoaminoxidase (IMAOs)

Os IMAOs são pouco utilizados em pacientes com comorbidades devido à hipotensão postural (40-60% dos pacientes) e à possibilidade de interações medicamentosas. Ao utilizar IMAOs, as preparações contendo simpatomiméticos (p. ex., anestésico local com adrenalina, descongestionantes nasais e sistêmicos), ADTs, ISRSs, estimulantes do SNC, morfina e derivados não podem ser prescritas. Alimentos contendo alta concentração de tiramina não podem ser consumidos devido ao risco de crise hipertensiva grave e suas consequências. Há uma lista desses alimentos no Capítulo 25. Devido a essas restrições e esses riscos, os IMAOs são cada vez menos prescritos.

Outros antidepressivos

A **mirtazapina** é útil para pacientes deprimidos mais agitados, com ansiedade, insônia e inapetência. Tem menos efeitos gastrointestinais e auxilia na redução da náusea e no aumento do apetite. É um antagonista misto de serotonina e de noradrenalina e exerce sua ação por meio do bloqueio específico de receptores pré-sinápticos alfa-2-adrenérgicos, aumentando a liberação de noradrenalina. Tem efeito similar no sistema serotoninérgico, estimulando os receptores 5-HT_{1A} e bloqueando os 5-HT₂ e 5-HT₃. É um antagonista potente de receptores histaminérgicos, causando pronunciada sedação e ganho de peso, efeitos que podem ser clinicamente desejáveis em pacientes clínicos com insônia ou baixo peso. A meia-vida plasmática é de 20 a 40 horas. Inibe

minimamente enzimas hepáticas. As doses devem ser reduzidas em até 50% nas insuficiências hepática e renal.^{41,42}

A **bupropiona** é útil quando a letargia, a fadiga e o retardo cognitivo e psicomotor são proeminentes. Tem efeito primariamente dopaminérgico e, secundariamente, noradrenérgico; não interage com receptores histaminérgicos e colinérgicos e não produz disfunção sexual, embora haja risco de priapismo. A meia-vida plasmática é de 21 horas. Os efeitos colaterais mais frequentes são agitação, ansiedade, *rash* cutâneo, tremores, diminuição do apetite, boca seca e obstipação intestinal. Pode haver aumento da pressão arterial. O risco de convulsões é bem maior do que o de outros antidepressivos, portanto, é preferível usar as formulações de liberação controlada. Seu uso não é recomendado em pacientes ansiosos ou com história de traumatismo craniano, tumores cerebrais, quadros cerebrais orgânicos ou alterações eletrencefalográficas. Deve-se evitar associação com outras drogas que diminuem limiar convulsivo, como ADTs, clozapina, haloperidol e lítio. Inibe minimamente a enzima hepática 2D6.^{41,42}

A **trazodona** é primariamente serotoninérgica (inibe a recaptação e antagoniza alguns de seus receptores). O bloqueio 5-HT₂ a torna uma opção farmacológica (isolada ou em combinação) em casos de disfunção sexual. A meia-vida plasmática é de 3 a 9 horas, aumentada pelas formulações de liberação controlada. Há risco de hipotensão postural (bloqueio alfa-adrenérgico), e a substância tem efeito sedativo (anti-histamínico) proeminente. Bom adjuvante em pacientes deprimidos com insônia proeminente.^{41,42}

A **agomelatina** é um agonista melatoninérgico, com bloqueio 5-HT_{2c}. Melhora o sono e produz menos efeitos adversos na função sexual.

A **vortioxetina** tem ação multimodal, ou seja, além de inibir a recaptação da serotonina, é agonista do receptor 5-HT_{1A} e antagonista de alguns outros receptores serotoninérgicos. Por isso, estimula a liberação de serotonina e modula indireta e positivamente a noradrenalina, a acetilcolina, a dopamina e a histamina, apesar de não agir diretamente nesses receptores. Essas ações estariam associadas com o efeito positivo na cognição e a ausência de eventos adversos de disfunção sexual nas doses habituais (estudos isolados com doses de 20 mg mostraram disfunção sexual maior que o placebo, embora menor do que com ISRSs e IRSNs). Ela não interfere na concentração plasmática de outros medicamentos, sendo segura para associações. Inibidores potentes da 2D6, quando coadministrados, podem vir a aumentar os níveis plasmáticos de vortioxetina.⁴³

Os **psicoestimulantes** parecem ser uma opção valiosa para alguns pacientes clínicos deprimidos com fadiga pronunciada. A melhora pode ocorrer dentro de dois dias de tratamento. Podem ser usados concomitantemente com os antidepressivos descritos. Potencializam o efeito analgésico e reduzem a sedação provocada por opioides. Os efeitos colaterais geralmente envolvem pequena elevação da frequência cardíaca e da pressão arterial, tensão e inquietude. Devem ser evitados em pacientes com arritmia cardíaca ou história de convulsões. Piora da inapetência não tem sido relatada; ao contrário, pode haver melhora.⁴⁴ No início do tratamento com metilfenidato, deve-se iniciar com doses baixas (2,5-5 mg, 2 vezes ao dia) e monitorar, a cada hora, por 4 horas, a frequência cardíaca e a pressão arterial. Essa droga pode ser aumentada de 2,5 a 5 mg por dia, até atingir 20 mg.⁴⁵

Os antidepressivos têm características que tornam seu uso mais ou menos favorável, dependendo das doenças físicas e/ou tratamentos concomitantes.³⁶ O Quadro 15.11 sintetiza esses cuidados de acordo com algumas doenças frequentes. O Capítulo 24 aborda o uso de psicofármacos em geral em diversas condições clínicas, incluindo gravidez e lactação.

QUADRO 15.11

Cuidados em relação a medicamentos antidepressivos de acordo com a condição comórbida

Condição	Riscos	Antidepressivos mais favoráveis
Dor crônica	Inibidores do citocromo 2D6 (fluoxetina, paroxetina) podem levar à perda da eficácia da codeína.	A amitriptilina é eficaz na redução da dor já em doses baixas (p. ex., 12,5 mg/dia), de forma independente da presença de depressão. A venlafaxina em doses maiores (≥ 150 mg/dia) e duloxetina (60 mg/dia) também, mas com menor eficácia e resultados controversos.
Doenças cardiovasculares (HAS, IAM, AVC)	Tricíclicos podem precipitar <i>delirium</i> e arritmias cardíacas, baixar o limiar convulsivante e aumentar o risco de hipotensão postural. Venlafaxina, desvenlafaxina, duloxetina e bupropiona podem aumentar a pressão arterial. É preciso cuidado em relação ao risco de aumento do intervalo QT com o uso de citalopram e escitalopram em indivíduos predispostos, em idosos e em doses mais altas. É preciso cuidado com as seguintes interações medicamentosas: inibidores do citocromo 2D6 podem aumentar níveis de digoxina, betabloqueadores, etc.; efeitos da varfarina e antiagregantes podem ser alterados por antidepressivos (é necessário monitorar).	Sertralina Caso seja necessário o uso de um tricíclico, a nortriptilina é o que causa menos hipotensão postural.
Obesidade	Tricíclicos, mirtazapina e paroxetina são os mais associados a aumento de peso. Outros antidepressivos levam a perda inicial, mas há recuperação do peso ao longo do tempo. A cirurgia bariátrica pode levar a alteração na absorção de antidepressivos e vitaminas.	ISRSs (exceto a paroxetina), IRSNs, bupropiona, vortioxetina.
Diabetes	Tricíclicos podem levar tanto a hiperglicemia como também aumentam o desejo por doces.	ISRSs (exceto paroxetina), IRSNs (cuidado com hipertensão, se presente), vortioxetina.
Epilepsia	Bupropiona, tricíclicos, maprotilina e metilfenidato reduzem o limiar convulsivante.	ISRSs e IRSNs.
Hipertrofia prostática	Tricíclicos podem levar a obstrução urinária pelos efeitos anticolinérgicos.	ISRSs (exceto paroxetina), IRSNs, vortioxetina.
Glaucoma	Tricíclicos, duloxetina e desvenlafaxina requerem cuidado quando usados em pacientes com glaucoma de ângulo estreito, pois podem levar a midríase.	ISRSs (exceto paroxetina) e IRSNs.
Hemorragias (HDA, etc.)	ISRSs aumentam o risco de hemorragia por depleção da serotonina plaquetária e aumentam o risco de HDA também por irritação direta.	HDA: tricíclicos auxiliam, pois reduzem a liberação de ácido clorídrico por bloqueio H2.
Câncer de mama	Perda do efeito do tamoxifeno com o uso concomitante de inibidores do citocromo 2D6 (fluoxetina, paroxetina e bupropiona).	Sertralina, escitalopram, citalopram e os IRSNs.

Parkinson

ISRSs e IRSNs podem precipitar e/ou piorar sintomas parkinsonianos.

Bupropiona tem efeito dopaminérgico, reduzindo sintomas parkinsonianos, mas pode precipitar sintomas psicóticos; tricíclicos ajudam pelo efeito anticolinérgico, mas podem piorar a cognição; selegilina é útil, mas perde a especificidade IMAO B em doses maiores que 10 mg/dia (cuidado com dieta e interações).

HAS = hipertensão arterial sistêmica; IAM = infarto agudo do miocárdio; AVC = acidente vascular cerebral; ISRSs = inibidores seletivos da recaptação de serotonina; IRSNs = inibidores da recaptação de serotonina e noradrenalina (duais); HDA = hemorragia digestiva alta; H2 = receptores histaminérgicos tipo 2.

ALGUMAS RECOMENDAÇÕES E ALERTAS

- As drogas utilizadas em psiquiatria são de 2 a 3 vezes mais eficazes que placebo e tão efetivas quanto a penicilina para a pneumonia pneumocócica ou a estreptomicina para a tuberculose.⁴⁶ Aproximadamente dois terços dos pacientes deprimidos tratados com um psicofármaco melhoram. Em um estudo abrangente, realizado com 2.876 pacientes, nos Estados Unidos, envolvendo vários níveis e alternativas de tratamento, a taxa de remissão cumulativa, após quatro tentativas de tratamento, foi de 67%.^{47,48}
- O uso de antidepressivos em crianças e adolescentes, bem como em adultos jovens, requer cuidados extras quanto ao surgimento de ideação suicida logo no início do tratamento. Recomendamos alertar pacientes e familiares quanto a esse raro efeito adverso e monitorar cuidadosamente a resposta ao tratamento. Em idosos, os efeitos benéficos dos antidepressivos são menos pronunciados.^{49,50}
- A indústria farmacêutica investe pelo menos US\$ 250 milhões na produção de um antidepressivo, e todo o esforço de *marketing* é empreendido para elevar a prescrição. Para se obter a aprovação da FDA, por volta de 2.500 pacientes participam de ensaios terapêuticos com a droga. Após essa fase de pesquisa, efeitos colaterais raros e outros problemas originados pelo amplo uso da droga podem deixar de ser registrados e veiculados com o mesmo cuidado.⁵¹
- Nos protocolos de pesquisa, os pacientes que testam novos antidepressivos são especialmente selecionados – tendem a ser mais jovens e saudáveis do que os atendidos no hospital geral, não fazem uso de outros medicamentos e frequentemente têm quadros clínicos menos graves. A maioria utiliza o novo antidepressivo por período inferior a quatro meses.
- Vários estudos consideram “melhora” da depressão uma redução de 50% na pontuação de determinada escala. Essa redução pode ter sido obtida apenas em alguns itens pouco específicos e não significar melhora dos principais sintomas da depressão. Cada vez mais ganha importância o problema de pacientes que permanecem com sintomas residuais da depressão. Isso tem motivado novos estudos, mais exigentes, que medem a taxa de remissão.
- Não raramente, a propaganda seleciona um único item da escala para ser motivo de comparação e de gráficos engenhosos (p. ex., destaca-se apenas um item da Escala de Depressão de Beck para comprovar redução de “suicidalidade”).
- Metanálises não são a “última palavra” sobre a eficácia de um fármaco. É importante verificar se todos os esforços foram empreendidos a fim de incluir dados de estudos não publicados. Feito isso, o efeito de um antidepressivo antes considerado eficaz pode mostrar-se igual ao do placebo (p. ex., reboxetina).⁵²
- Deve-se estar atento à dose correta e ao tempo mínimo de uso de um antidepressivo antes de decidirmos pela mudança de droga. Nos casos de melhora parcial, deve-se buscar a potencialização e a combinação de drogas,⁵³ mas tais recursos não são abordados neste capítulo.
- Mais recentemente, vários estudos têm associado variações genéticas à resposta terapêutica propiciada por psicofármacos.⁵⁴ O tema é abordado no Capítulo 23. No caso da depressão, os principais genes pesquisados pela farmacogenética são os que codificam proteínas

relacionadas à farmacodinâmica (neurotransmissão serotoninérgica, cascata de segundos mensageiros, neuroplasticidade, sinalização de glicocorticoides) e à farmacocinética dos antidepressivos.⁵⁵ A genotipagem das enzimas do citocromo P450, relacionadas ao metabolismo da maioria dos antidepressivos disponíveis, é ainda muito cara e reservada apenas aos casos de resistência ao tratamento ou de muitos efeitos colaterais.⁵⁶

REFERÊNCIAS

1. Vos T, Flaxman AD, Naghavi M, Lozano R, Michaud C, Ezzati M, et al. Years lived with disability for 1160 sequelae of 289 diseases and injuries 1990-2010: a systematic analysis for the Global Burden of Disease Study 2010. *Lancet*. 2012;380(9859):2163-96.
2. Cavanaugh SVA, Furlanetto LM, Creech SD, Powell LH. Medical illness, past depression, and present depression: a predictive triad for in-hospital mortality. *Am J Psychiatry*. 2001;158:43-8.
3. Fráguas R Jr, Alves TCTF. Depressão no hospital geral: estudo de 136 casos. *Rev Assoc Med Bras*. 2002;48(3):225-30.
4. Furlanetto LM, Silva RV da, Bueno JR. The impact of psychiatric comorbidity on length of stay of medical inpatients. *Gen Hosp Psychiatry*. 2003;25(1):14-9.
5. Furlanetto LM, Brasil MA. Diagnosticando e tratando depressão no paciente com doença clínica. *J Bras Psiquiatr*. 2006;55(1):8-19.
6. Henriques SG, Fráguas R, Iosifescu DV, Menezes PR, Lucia MC, Gattaz WF, et al. Recognition of depressive symptoms by physicians. *Clinics*. 2009;64(7):629-35.
7. Lépine J-P, Briley M. The increasing burden of depression. *Neuropsychiatr Dis Treat*. 2011;7(1):3-7.
8. Bostwick JM, Pankratz VS. Affective disorders and suicide risk: a reexamination. *Am J Psychiatry* 2000;157(12):1925-32.
9. Cigognini MA, Furlanetto LM. Diagnosis and pharmacological treatment of depressive disorders in a general hospital. *Rev Bras Psiquiatr*. 2006;28(2):97-103.
10. Botega NJ, Silveira GM. General practitioners' attitudes towards depression: a study in primary care setting in Brazil. *Int J Soc Psychiatry*. 1996;42(6):230-7.
11. Andrade L, Walters EE, Gentil V, Laurenti R. Prevalence of ICD-10 mental disorders in a catchment area in the city of São Paulo, Brazil. *Soc Psychiatry Psychiatr Epidemiol*. 2002;37(7):316-25.
12. Botega, NJ, Mitsuuchi GN, Azevedo, RCS, Lima, DD, Fanger, PC, Mauro, MLF, et al. Depression, alcohol use disorders and nicotine dependence among patients at a general hospital. *Rev Bras Psiquiatr*. 2010;32(3):250-6.
13. Gaspar KC, dos Santos A Jr, de Azevedo RC, Mauro ML, Botega NJ. Depression in general hospital inpatients: challenges for consultation-liaison psychiatry. *Rev Bras Psiquiatr*. 2011;33(3):305-7.
14. Marques CA, Biava P, Medeiros BV, Stefanello B, Furlanetto LM. Associação entre depressão, apoio social e dor em pacientes internados devido a doenças físicas. *Rev Bras Psiquiatr*. 2010;32:S35.
15. Hooten WM. Chronic pain and mental health disorders: shared neural mechanisms, epidemiology, and treatment. *Mayo Clin Proc*. 2016;91(7):955-70.
16. Frasure-Smith N, Lespérance F, Talajic M. Depression following myocardial infarction: impact on 6-month survival. *JAMA*. 1993;270(15):1819-25.

17. Cowles M, Nemeroff CB. Depression: a systemic illness. In: Blumenfield M, Strain JJ, editors. Psychosomatic medicine. Philadelphia: Lippincott Williams & Wilkins; 2006. p. 47-65.
18. Lichtman JH, Bigger JT Jr, Blumenthal JA, Frasure-Smith N, Kaufmann PG, Lespérance F, et al. Depression and coronary heart disease: recommendations for screening, referral, and treatment: a science advisory from the American Heart Association Prevention Committee of the Council on Cardiovascular Nursing, Council on Clinical Cardiology, Council on Epidemiology and Prevention, and Interdisciplinary Council on Quality of Care and Outcomes Research: endorsed by the American Psychiatric Association. *Circulation*. 2008;118(17):1768-75.
19. Badescu SV, Tataru C, Kobylinska L, Georgescu EL, Zahiu DM, Zagrean AM, et al. The association between diabetes mellitus and depression. *J Med Life*. 2016;9(2):120-5.
20. Carnes-Vendrell A, Deus-Yela J, Molina-Seguin J, Pifarreparedero J, Purroy F. Update on post-stroke depression: posing new challenges in patients with a minor stroke or transient ischaemic attack. *Rev Neurol*. 2016;62(10):460-7.
21. Warrington TP, Bostwick JM. Psychiatric adverse effects of corticosteroids. *Mayo Clin Proc*. 2006;81(10):1361-7.
22. American Psychiatric Association. Diagnostic and statistical manual of mental disorders: DSM-5. 5th ed. Washington: APA; 2013.
23. Spedding S. Vitamin D and depression: a systematic review and meta-analysis comparing studies with and without biological flaws. *Nutrients*. 2014;6;1501-18.
24. Kerr DC, Zava DT, Piper WT, Saturn SR, Frei B, Gombart AF. Associations between vitamin D levels and depressive symptoms in healthy young adult women. *Psychiatry Res*. 2015;227(1):46-51.
25. Furlanetto LM. Estratégias psicoterapêuticas em interconsulta. *Rev Bras Psicoter*. 2006;8(1):87-98.
26. Ferreira MHF, Colombo ES, Guimarães PS, Soeiro RE, Dalgalarrrondo P, Botega NJ. Suicide risk among inpatients at a university general hospital. *Rev Bras Psiquiatr*. 2007;29(1):51-4.
27. Botega NJ, Azevedo RCS, Mauro MLF, Mitsuushi GN, Fanger PC, Lima DD, et al. Factors associated with suicide ideation among medically and surgically hospitalized patients. *Gen Hosp Psychiatry*. 2010;32(4):396-400.
28. Furlanetto LM, Mendlowicz MV, Romildo Bueno J. The validity of the beck depression inventory-short form as a screening and diagnostic instrument for moderate and severe depression in medical inpatients. *J Affect Disord*. 2005;86(1):87-91.
29. Zigmond AS, Snaith RP. The hospital anxiety and depression scale. *Acta Psychiatr Scand*. 1983;67(6):361-70.
30. Botega NJ, Bio MR, Zomignani MA, Garcia Jr C, Pereira WAB. Transtornos do humor em enfermagem de clínica médica e validação de escala de medida (HAD) de ansiedade e depressão. *Rev Saúde Pública*. 1995;29(5):355-63.

31. Bjelland I, Dahl AA, Haug TT, Neckelmann D. The validity of the hospital anxiety and depression scale: an updated literature review. *J Psychosom Res.* 2002;52(2):69-77.
32. Wakefield CE, Butow PN, Aaronson NA, Hack TF, Hulbert-Williams NJ, Jacobsen PB, et al. Patient-reported depression measures in cancer: a meta-review. *Lancet.* 2015;2(7):635-47.
33. Furlanetto LM, Del Moral JAG, Gonçalves AHB, Rodrigues K, Jacomino ME. Diagnosticando depressão em pacientes internados com doenças hematológicas: prevalência e sintomas associados. *J Bras Psiquiatr.* 2006;55(2):96-101.
34. Abrams R. *Electroconvulsive therapy.* 2nd ed. New York: Oxford University; 1992.
35. Nierenberg AA, Alpert JE. Depressive breakthrough. *Psychiatr Clin North Am.* 2000;23(4):731-42.
36. Furlanetto LM. Psicofarmacologia em pacientes com doenças clínicas. In: Sena EP, Miranda-Scippa AMA, Quarantini LC, Oliveira IR, editores. *Irismar: psicofarmacologia clínica.* 3. ed. Rio de Janeiro: Medbook; 2011. p. 585-95.
37. Lam RW. Psychopharmacology for the clinician. Antidepressants and QTc prolongation. *J Psychiatry Neurosci.* 2013;38(2):E5-6.
38. Lötsch J, Skarke C, Wieting J, Oertel BG, Schmidt H, Brockmöller J, et al. Modulation of the central nervous effects of levomethadone by genetic polymorphisms potentially affecting its metabolism, distribution, and drug action. *Clin Pharmacol Ther.* 2006;79(1):72-89.
39. Kelly CM, Juurlink DN, Gomes T, Duong-Hua M, Pritchard KI, Austin PC, et al. Selective serotonin reuptake inhibitors and breast cancer mortality in women receiving tamoxifen: a population based cohort study. *BMJ.* 2010;340:c693.
40. Fava GA, Gatti A, Belaise C, Guidi J, Offidani E. Withdrawal symptoms after selective serotonin reuptake inhibitor discontinuation: a systematic review. *Psychother Psychosom.* 2015; 84:72-81.
41. Schatzberg AF, DeBattista C. *Manual of clinical psychopharmacology.* 8th ed. Washington: APA; 2015.
42. Bazire S. *Psychotropic drug directory.* Aberdeen: HealthComm; 2014.
43. Sanchez C, Asin KE, Artigas F. Vortioxetine, a novel antidepressant with multimodal activity: Review of preclinical and clinical data. *Pharmacol Ther.* 2015;145:43-57.
44. Li M, Rodin G. Depression. In: Levenson JL, editor. *The American Psychiatric Publishing textbook of psychosomatic medicine: psychiatric care of the medically ill.* 2nd ed. Washington: APA; 2011. p. 175-97.
45. Orr K, Taylor D. Psychostimulants in the treatment of depression: a review of the evidence. *CNS Drugs.* 2007;21(3):239-57.
46. Davis JM, Wang Z, Janicak PG. Psychiatric medication compares favorably to drugs used in internal medicine: a meta-analysis. *Schizophr Res.* 1995;15(1):148.
47. Gaynes BN, Rush AJ, Trivedi MH, Wisniewski SR, Balasubramani GK, McGrath PJ, et al. Primary versus specialty care outcomes for depressed outpatients managed with measurement-based care: results from STAR*D. *J Gen Intern Med.* 2008;23(5):551-60.

48. Hetem LAB, Chagas MHN. Visão crítica dos avanços na terapêutica da depressão. In: Brasil MAA, Botega NJ, Hetem LAB. Programa de educação continuada da Associação Brasileira de Psiquiatria (PEC-ABP). Rio de Janeiro: ABP; 2010. p. 105-12.
49. Tedeschini E, Levkovitz Y, Iovieno N, Ameral VE, Nelson JC, Papakostas GI. Efficacy of antidepressants for late-life depression: a meta-analysis and meta-regression of placebo-controlled randomized trials. *J Clin Psychiatry*. 2011;72(12):1660-8.
50. Maust DT, Oslin DW, Thase ME. Going beyond antidepressant monotherapy for incomplete response in nonpsychotic late-life depression: a critical review. *Am J Geriatr Psychiatry*. 2013;21(10):973-86.
51. Burke MJ, Preskorn SH. Psychopharmacology the fourth generation of progress. In: Bloom FE, Kupfer DJ, editors. Short-term treatment of mood disorders with standard antidepressants. New York: Raven; 1995. p. 1053-65.
52. Godlee F, Loder E. Missing clinical trial data: setting the record straight. *BMJ*. 2010;341:c5641.
53. Rocha FL, Fuzikawa C, Riera R, Hara C. Combination of antidepressants in the treatment of major depressive disorder: a systematic review and meta-analysis. *J Clin Psychopharmacol*. 2012;32(2):278-81.
54. Fabbri C, Serretti A. Pharmacogenetics of major depressive disorder: top genes and pathways toward clinical applications. *Curr Psychiatry Rep*. 2015;17(7):50.
55. Spina E, de Leon J. Clinical applications of CYP genotyping in psychiatry. *J Neural Transm*. 2015;122(1):5-28.
56. Spadaler J, Tuson M, Lopez-Ibor JM, Lopez-Ibor F, Lopez-Ibor MI. Pharmacogenetic testing for the guidance of psychiatric treatment: a multicenter retrospective analysis. *CNS Spectr*. 2016;21:1-10.

[NT] O índice de remissão proporcionado pela ECT fica entre 80 e 90%, contra 60 a 70%, nos ensaios terapêuticos com antidepressivos. A mortalidade atribuída à ECT é baixa, menor do que a associada ao uso de ADT e igual à da anestesia para pequenas cirurgias: 1 morte em 10 mil pacientes tratados.³⁴



Comportamento suicida

Neury José Botega
Carlos Filinto da Silva Cais

Os índices de suicídio aumentaram no Brasil, diferentemente do que se passou na maioria dos países neste início do século. Em pelo menos 90% dos casos, uma doença mental estava entre os fatores que levaram ao suicídio. No hospital geral, é frequente o atendimento de pessoas que tentaram o suicídio. Entre os pacientes internados, o risco de suicídio é maior nos três seguintes grupos: nos admitidos por tentativa de suicídio; nos potencialmente instáveis e impulsivos; e nos que estão sob o impacto de algo que leva ao desespero, como um diagnóstico de doença grave. As três principais funções do psiquiatra em relação ao comportamento suicida são: identificar o risco; proteger o paciente; e incluir no manejo e, se possível, remover ou diminuir o impacto dos fatores de risco. A ideação suicida deve ser avaliada em todas as consultas. Quando há risco iminente de suicídio, é preciso manter o paciente a salvo, de modo que todo o esforço deve se voltar para esse objetivo. Ações rápidas e objetivas exigem do profissional disponibilidade e prontidão. Em contrapartida, deve haver capacidade de ouvir o paciente com calma, respeito e sem julgamentos. O suicídio causa forte impacto em todos, notadamente na equipe assistencial, em geral sem treinamento para avaliar e manejar situações de risco.

As várias definições de suicídio costumam conter a ideia central, mais evidente, ligada ao ato de terminar com a própria vida, além de ideias periféricas, menos evidentes, relacionadas à motivação, à intencionalidade e à letalidade. Podemos nos referir ao comportamento suicida como todo ato pelo qual um indivíduo causa lesão a si mesmo, qualquer que seja o grau de intenção letal e de conhecimento do verdadeiro motivo para isso. Essa noção abrangente evita a tendência de se valorizar, exageradamente, a intencionalidade e a lucidez de consciência durante o ato suicida.¹

A visão em relação ao suicídio tem mudado ao longo da história – de um evento aceitável ou constituinte da tradição em certas culturas a pecado, na Idade Média, dilema humano, no século XVII e, no século XIX, sinal de doença mental.² Atualmente, documentos da Organização Mundial da Saúde (OMS) encaram o suicídio como problema de saúde pública e enfatizam a necessidade de prevenção. Em contrapartida, discute-se a possibilidade de, em certas circunstâncias, ser o suicídio uma opção legítima, o exercício racional de um direito pessoal.^{1,3}

Diferentes atitudes em relação ao suicídio não se encerram em períodos da história; elas persistem, com maior ou menor força, no âmago de cada um de nós e têm o poder de conduzir nossas ações. Nossas atitudes influenciam o que fazemos ou deixamos de fazer pelos pacientes que atendemos (Quadro 16.1).

QUADRO 16.1

Crenças errôneas em relação ao suicídio

Se eu perguntar sobre suicídio, poderei induzir o paciente a isso.

Diferentemente de uma crença comum, questionar sobre suicídio não inocula essa ideia na mente de uma pessoa. A pergunta, se feita de modo sensato e franco, fortalece o vínculo com o paciente, que passa a se sentir aliviado e acolhido por um profissional cuidadoso e interessado na extensão de seu sofrimento.

Ele está ameaçando o suicídio apenas para manipular.

Ainda que, em alguns casos, possa haver um componente manipulativo, a avaliação clínica deve ser cuidadosa; não se deve desconsiderar o risco.

Quem quer se matar se mata mesmo.

Essa crença pode conduzir à imobilidade. As pessoas que pensam em suicídio frequentemente estão ambivalentes entre viver ou morrer. Quando obtêm apoio emocional no momento certo, podem desistir do suicídio.

No lugar dele, eu também me mataria.

Há sempre o risco de o profissional se identificar com aspectos do desamparo e da desesperança de seus pacientes, sentindo-se impotente. Há também o perigo de se valer de um julgamento pessoal para iniciar ou não ações de prevenção.

Veja se, da próxima vez, você se mata mesmo!

O comportamento suicida desencadeia sentimentos de hostilidade e rejeição. Isso nos impede de tomar a tentativa de suicídio como um marco a partir do qual podem se mobilizar forças para uma mudança de vida.

Quem se mata é bem diferente de quem apenas tenta.

Vistas em conjunto, as pessoas que tentam o suicídio têm características diferentes daquelas que de fato o cometem. No entanto, devemos ter cuidado ao extrapolar achados de estudos populacionais a situações individuais. Há muita heterogeneidade quanto a motivação, intenção e grau de letalidade.

Fonte: Botega.⁴

A compreensão do fenômeno do suicídio deve cotejar contribuições de vários campos do conhecimento. Diferentes abordagens teóricas, sejam biomédicas, psicológicas, sejam sociais ou filosóficas, costumam ampliar nossa visão e nossa inquietude por compreender (Quadro 16.2). Reconhecer o valor de diferentes disciplinas e avaliar o poder da combinação de vários fatores na determinação do comportamento suicida é fundamental para nortear a prática do profissional da saúde.

QUADRO 16.2

Resumo de algumas abordagens teóricas sobre o suicídio

Émile Durkheim escreveu, em 1897, *O suicídio: estudo sociológico*. O suicídio foi concebido como um fato social associado a diferentes graus de coesão e de integração sociais. Quatro tipos de suicídio foram caracterizados. O *suicídio egoístico* é observado em indivíduos que perderam o sentido de integração com a sociedade e a influência das forças sociais. Haveria isolamento, individualismo mórbido e falta de sentido na vida. O *suicídio anômico* é observado nas sociedades em crise, quando há ausência ou enfraquecimento das normas de integração social e diminuição da solidariedade. O estado de desregramento cria um desequilíbrio entre desejos ili-mitados e as possibilidades de satisfação. Com o passar do tempo, o conceito de anomia foi expandido para explicar o maior número de suicídios em áreas de grandes cidades onde se encontra diminuição ou ausência de padrões de conduta, isolamento social e anonimato. No *suicídio altruísta*, há demasiada integração social a encorajar o sacrifício da própria vida. O *suicídio fatalista* ocorre em situações de intensa pressão social, como se observa em prisões e em cidades sitiadas pelo inimigo.⁵

A **propensão biológica** que contribui para a ocorrência de alguns suicídios não é específica. Ela se encontra igualmente associada a outras manifestações do binômio agressividade/impulsividade e é fomentada pela presença de transtornos mentais. Há um interesse crescente em fatores genéticos que sejam independentes de patologias específicas, mas que se associem a anormalidades neurobiológicas ou a perfis clínicos estáveis ao longo do tempo (*endofenótipos*), como agressividade/impulsividade, deficiências no sistema serotoninérgico, nível de cortisol em resposta ao estresse e desempenho em testes de tomada de decisões. Outra linha de pesquisa incorpora fatores ambientais no modelo de suscetibilidade: a partir de situações traumáticas ocorridas precocemente na infância, desregula-se a expressão de certo número de genes envolvidos em funções normais do cérebro (*alterações epigenéticas*). Essa desregulação vem sendo frequentemente encontrada em casos de suicídio. Espera-se que, uma vez identificados, marcadores biológicos possam auxiliar na avaliação clínica, bem como abrir portas para o tratamento de estados psíquicos, biologicamente condicionados, que aumentam o risco de suicídio.^{6,7}

A **visão psicodinâmica** refere-se a fantasias inconscientes de imortalidade, de vingança, de restabelecimento de vínculos perdidos ou ameaçados e de controle onipotente. O ato suicida pode resultar do abalo à invulnerabilidade narcísica, com intolerância à dor da perda e à impotência.⁸

Algumas relações interpessoais têm natureza simbiótica. Há uma tentativa de reduzir o outro a si mesmo em uma relação idealizada. Após a fase de apaixonamento narcísico (simbiótica), não há individuação e amadurecimento da relação. Quando surgem dificuldades e rompimentos, o vínculo, antes ideal, transforma-se em vínculo aterradorante ou vazio desesperador.⁹

Em nosso meio, Cassorla¹⁰ investigou a trajetória de vida de adolescentes do sexo feminino que tentam o suicídio. Em geral, elas vêm de famílias desestruturadas, e há dificuldade de estabelecimento de vínculos afetivos e de modelos de identificação. De estrutura egoica frágil, essas jovens buscam relações simbióticas com seus parceiros. Qualquer ameaça de ruptura de relacionamento desencadeia imensa angústia, com sentimentos de desintegração e aniquilamento. Daí as repetidas tentativas de suicídio como recurso desesperado para manter vínculos afetivos.

O ato suicida pode ser entendido como um ato-dor, em que a força de conteúdos psíquicos irrepresentáveis leva ao predomínio do traumático. O ocorrido escapa do universo representacional do sujeito, o que impede o processamento da dor em termos de sofrimento, com identificação de sentimentos e intermediação de palavras. A cisão suscitada pelo trauma psíquico incapacita o sujeito de ser dono de seu destino. Ocorre, então, a *passagem ao ato*: não suportando manter-se em cena, o sujeito se evade, em um ato-dor.¹¹

Na **visão cognitivo-comportamental**, a tentativa de suicídio é uma forma extrema de esquiva. Contingências coercitivas, como o reforço negativo e a punição, incrementam e mantêm tal comportamento. Após uma tentativa de suicídio, ocorrem mudanças ambientais (reforçadores familiares e sociais) que podem aumentar ou diminuir a probabilidade de novos atos suicidas.¹²

Pessoas que tentam o suicídio são mais sensíveis a estímulos que sinalizam fracassos e rejeições, constroem distorções cognitivas no sentido de se sentirem frequentemente enganadas, sem escapatória, e não conseguem antecipar cenários positivos. Há mais dificuldade na resolução de problemas pessoais e interpessoais. A rigidez cognitiva e o pensamento dicotômico acabam por levar à busca de soluções do tipo *tudo ou nada*.¹³

MAGNITUDE

O coeficiente de mortalidade por suicídio representa o número de suicídios para cada 100 mil habitantes ao longo de um ano. A Tabela 16.1 contém os países que apresentam os coeficientes mais altos estimados para o ano de 2012, total de óbitos por suicídio e percentual de mudança dos coeficientes entre 2000 e 2012, e a Tabela 16.2, os coeficientes de países selecionados. O coeficiente global encontra-se em 11,4 (15 para homens e 8 para mulheres).¹ Tal coeficiente diminuiu 28% em um decênio. Em oposição à tendência mundial, em poucos países (17%), observou-se elevação nos índices de suicídio. O Brasil encontra-se nesse subgrupo.

Tabela 16.1

Países com os maiores coeficientes padronizados de mortalidade por suicídio, estimados para o ano de 2012, total de óbitos por suicídio e percentual de mudança dos coeficientes entre 2000 e 2012

País	Coeficiente de mortalidade por suicídio (suicídio/100 mil)	Número absoluto de suicídios	Mudança no coeficiente entre 2000 e 2012 (%)
Guiana	44,2	377	-1
Coreia do Sul	28,9	17.908	109
Sri Lanka	28,8	6.170	-45
Lituânia	28,2	1.007	-37
Suriname	27,8	145	40
Cazaquistão	23,8	3.912	-36
Burundi	23,1	1.617	18
Índia	21,1	258.075	-9
Rússia	19,5	31.997	-44
Hungria	19,1	2.519	-26
Japão	18,5	39.442	-2
Bielorrússia	18,3	2.051	-48
Ucrânia	16,8	9.165	-43
França	16,3	10.093	-17
Letônia	16,2	419	-44
Finlândia	14,8	901	-29
Bélgica	14,2	1.955	-21
Angola	13,8	2.206	50
Moldávia	13,7	566	-11
Estônia	13,6	226	-46

Fonte: Com base em World Health Organization.¹

Tabela 16.2

Estimativas de coeficientes padronizados de mortalidade por suicídio, número absoluto de suicídios e variação percentual entre 2000 e 2012 em alguns países

País	Coeficiente de mortalidade por suicídio (suicídio/100 mil)	Número absoluto de suicídios	Mudança no coeficiente entre 2000 e 2012 (%)
América Latina			

Chile	12,2	2.262	14
Bolívia	12,2	1.224	-2
Uruguai	12,1	469	-18
Cuba	11,4	1.648	-22
Argentina	10,3	4.418	-17
Brasil	5,8	11.821	10
Colômbia	5,4	2.517	-22
México	4,2	4.951	16
Outros países selecionados			
Estados Unidos	12,1	43.361	24
Austrália	10,6	2.679	-10
Alemanha	9,2	10.745	-17
Portugal	8,2	1.321	-9
China	7,8	120.730	-59
Reino Unido	6,2	4.360	-21
Espanha	5,1	3.296	-20
Itália	4,7	3.908	-7
Grécia	3,8	548	10
África do Sul	3	1.398	-9
Egito	1,7	52	-33
Kuwait	0,9	33	-35
Síria	0,4	77	-13

Fonte: Com base em World Health Organization.¹

A despeito de um coeficiente de mortalidade relativamente baixo, o Brasil, por ser populoso, ocupa o oitavo lugar entre os países que registram os maiores números de mortes por suicídio. Em 2012, houve 11.821 suicídios oficialmente registrados no País, o que representa, em média, 32 mortes por dia.¹ Essas cifras devem estar subestimadas em pelo menos 20%.⁴

Certas localidades, bem como alguns grupos populacionais, como o de agricultores no interior do Estado do Rio Grande do Sul, têm coeficientes que superam 15 por 100 mil por ano. Em jovens indígenas do Centro-Oeste, as taxas de suicídio chegam a ser 18 vezes maiores do que o observado em não indígenas.¹⁴⁻¹⁶

No Brasil, a relação do coeficiente de suicídio entre os sexos masculino e feminino é de aproximadamente 4:1.¹⁵ Predominam, entre os homens, as mortes por enforcamento (58%), arma de fogo (17%) e ingestão de pesticidas (5%). Entre as mulheres, o enforcamento (49%), seguido de fumaça/fogo (9%), precipitação de altura (6%), arma de fogo (6%) e ingestão de pesticidas (5%).¹⁷

No espectro do comportamento autoagressivo, o suicídio é a ponta de um *iceberg*. Estima-se que o número de tentativas de suicídio supere o de suicídios em, pelo menos, dez vezes. Há considerável contingente de pessoas que pensam seriamente em pôr fim à vida, estimado por estudos internacionais entre 2 e 19%, com proporção maior de mulheres.^{18,19}

Um estudo realizado na área urbana do município de Campinas (SP) mostrou que, ao longo da vida, 17% das pessoas haviam pensado seriamente em pôr fim à vida, 5% chegaram a elaborar um plano para tanto, e 3% já haviam tentado o suicídio (Figura 16.1). Destas, de cada três, apenas uma foi atendida em um pronto-socorro.²⁰

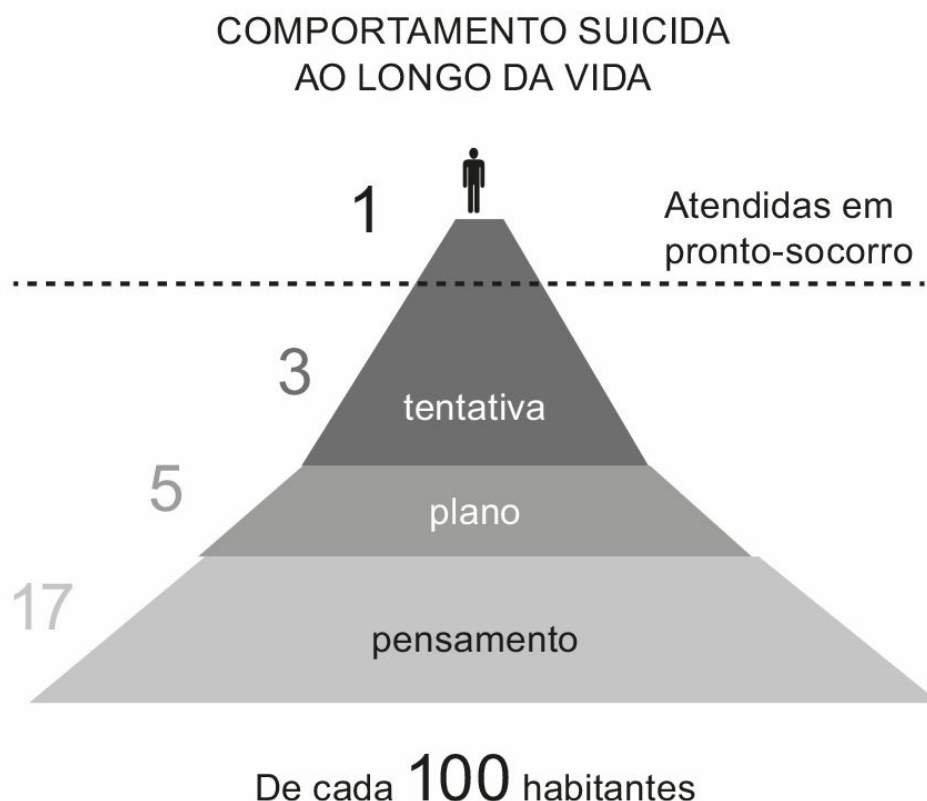


FIGURA 16.1 Prevalência de comportamento suicida na região urbana de Campinas (SP).

Fonte: Com base em Botega e colaboradores.²⁰

Um estudo nacional que avaliou 1.560 jovens entre 18 e 24 anos mostrou que o comportamento suicida caminha ao lado de vários outros riscos de agravos à saúde, como acidentes automobilísticos, envolvimento em briga com agressão física, porte de arma branca ou arma de fogo, uso abusivo de álcool e de outras substâncias psicoativas e relação sexual sem uso de preservativo.²¹

Em hospitais gerais, a incidência de suicídios é de 3 a 5 vezes maior do que na população em geral. A maioria das mortes se dá por precipitação de altura ou enforcamento. Ausência de redes de proteção, janelas em andares elevados, banheiros com trancas, acesso indevido a medicações e instrumentos perfurocortantes, bem como falta de preparo da equipe, agravam o risco de suicídio.²²

Entre os pacientes de hospitais gerais, a frequência de suicídios é maior nos três seguintes grupos: os que se recuperam de uma tentativa de suicídio e que mantêm a intenção de pôr fim à vida; os pacientes potencialmente instáveis e impulsivos (como os que sofrem de *delirium* ou de abstinência de drogas); e os que estão sob pressão de uma doença crônica reagudizada ou sob o impacto de um diagnóstico descoberto recentemente.²²

A ideação suicida é frequente em pacientes clínicos e cirúrgicos e sinaliza provável transtorno mental comórbido. A prevalência de ideação suicida em uma amostra de 4.328 pacientes

internados em enfermarias do Hospital de Clínicas da Universidade Estadual de Campinas (HC Unicamp) foi de 5%, em média, associada a depressão, uso abusivo de bebidas alcoólicas e tabagismo.^{23,24}

AVALIAÇÃO DO RISCO DE SUICÍDIO

O risco de suicídio não é estático, e não há fórmula simples nem escalas que possam estimá-lo com precisão. A avaliação do risco de suicídio distancia-se da noção de previsão de quem irá ou não tirar a própria vida. Ela tem a função de orientar o manejo clínico e colocar as ações terapêuticas em ordem de prioridade.

A fim de auxiliar na sistematização da coleta de um grande volume de informações, a Figura 16.2 e um anexo, ao fim do capítulo, contêm as dimensões que devem orientar a avaliação do risco de suicídio.

- 1.** O que está acontecendo?
 - Eventos precipitantes
 - Estressores agudos e crônicos
- 2.** Estado mental atual
 - Afetos intensos
 - Constricção cognitiva
- 3.** Intencionalidade suicida
 - Ideia
 - Plano
- 4.** Principais fatores de risco e de proteção
 - Transtornos mentais
 - Tentativa de suicídio pregressa
 - História
 - Personalidade
- 5.** Formulação do risco de suicídio
 - Registro
 - Comunicação

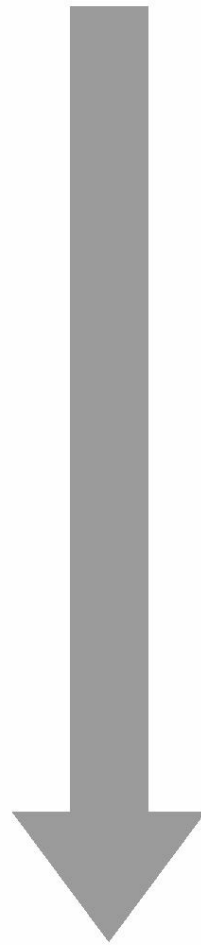


FIGURA 16.2 Informações sequenciais constantes de uma avaliação de risco de suicídio.

1. O que está acontecendo?

A entrevista inicial tem dois objetivos: um semiológico, com coleta de várias informações, e outro relacional, com provimento de apoio emocional e vinculação. O mais importante é procurar compreender o ponto de vista do paciente. Não há lugar para comentários rapidamente apaziguadores que pareçam desconsiderar o sofrimento da pessoa.

O primeiro contato pode ocorrer em condições pouco favoráveis, se o paciente estiver reticente, sonolento ou recebendo cuidados médicos intensivos. A autoagressão pode ser negada, embora familiares e equipe médica façam referência a uma tentativa de suicídio. É preciso cautela, pois o relato de fontes secundárias de informação costuma mesclar fatos com interpretações.

O paciente poderá referir uma frustração, um conflito ou uma necessidade. É preciso ouvir atentamente o que a pessoa precisa (consegue) nos dizer e aceitar sua urgência. Além disso, é importante atentar para o conteúdo latente do que se ouve – sentimentos indiscriminados e conflituosos, falsas crenças ou pensamentos automáticos que impedem uma visão mais ampla. Tudo isso poderá ser abordado mais tarde, com calma, quando houver maior capacidade para a reflexão.

2. Fatores de risco

Os fatores de risco derivam da consolidação de dados oriundos de estudos populacionais. Na prática clínica, deve-se raciocinar da seguinte forma: se o paciente apresentar fatores de risco para o suicídio, a possibilidade de vir a se matar deve ser considerada.²⁵ Trata-se de um salto referencial, do populacional para a singularidade da pessoa. No entanto, é assim que costumamos proceder, e, entre os vários elementos depositados na balança das decisões clínicas, encontram-se os fatores *sinalizadores* de risco (Quadro 16.3).

QUADRO 16.3

Fatores de risco para o suicídio

Sociodemográficos

- Sexo masculino
- Adultos jovens (19-49 anos) e idosos
- Estados civis viúvo, divorciado e solteiro
- Orientação homo ou bissexual
- Ateus, protestantes tradicionais > católicos, judeus
- Grupos étnicos minoritários

Transtornos mentais

- Depressão, transtorno bipolar, abuso/dependência de álcool e de outras drogas, esquizofrenia, transtornos da personalidade (especialmente *borderline*)
- História familiar de doença mental
- Falta de tratamento adequado em saúde mental
- Ideação ou plano suicida
- Tentativa de suicídio pregressa
- História familiar de suicídio

Psicossociais

- Abuso físico ou sexual
- Perda ou separação dos pais na infância
- Instabilidade familiar
- Ausência de apoio social
- Isolamento social
- Perda afetiva recente ou outro acontecimento estressante
- Datas importantes (reações de aniversário)
- Desemprego
- Aposentadoria
- Violência doméstica
- Desesperança, desamparo

- Ansiedade intensa
- Vergonha, humilhação (*bullying*)
- Baixa autoestima
- Desesperança
- Traços de personalidade: impulsividade, agressividade, labilidade do humor, perfeccionismo
- Rigidez cognitiva, pensamento dicotômico
- Pouca flexibilidade para enfrentar adversidades

Outros

- Acesso a meios letais (arma de fogo, venenos)
- Doenças físicas incapacitantes, estigmatizantes, dolorosas, terminais
- Estados confusionais orgânicos
- Falta de adesão ao tratamento, agravamento ou recorrência de doenças preexistentes
- Relação terapêutica frágil ou instável

A **tentativa de suicídio** é o principal fator de risco para um futuro suicídio. Por isso, deve ser encarada com seriedade, como um sinal de alerta a indicar a atuação de fenômenos psicossociais complexos.²⁶

Qualquer ato de autoagressão implica maior risco de suicídio.^[NT] A história de repetidas tentativas de suicídio, com baixa intenção letal e sem complicações clínicas, não pode ser desconsiderada. As circunstâncias e as consequências das tentativas de suicídio devem ser detalhadas.

Um grupo de interesse especial é constituído por pacientes que repetidamente se ferem com lâminas de barbear, cacos de vidro ou com cigarros. Em geral, os atos são explicados como uma tentativa de diminuir a angústia e a vivência de despersonalização. A visão do próprio sangue é acompanhada por sensação de alívio e prazer. Baixa autoestima, humor instável, comportamento impulsivo, instabilidade nos relacionamentos e abuso de álcool e de outras drogas são frequentemente encontrados nesse grupo.²⁷⁻²⁹

O **transtorno mental** é um fator de risco quase obrigatório, ainda que insuficiente, para o suicídio. Isso ocorre por diversas razões, como a condição clínica que dificulta a adaptação à sociedade, leva à estigmatização; diminui a adaptação funcional e a qualidade de vida; frequentemente provoca instabilidade de humor e sentimentos dolorosos, como ansiedade, raiva e frustração; representa um ônus emocional e financeiro para o indivíduo e a família; e predispõe a vários estresses situacionais.³⁰

Em hospitais gerais, além da depressão e da agitação psicomotora, o abuso de substâncias é outro fator de risco para o suicídio, quando há intoxicação ou abstinência. Além disso, os quadros psiquiátricos caracterizados por confusão mental e agitação psicomotora relacionada a uma doença clínica ou a seus tratamentos também representam fatores de risco.³¹

Quando mais de um transtorno mental se combinam, como depressão e alcoolismo, ou, ainda, coexistem depressão, ansiedade e inquietude motora, há maior risco de suicídio.

No caso de pacientes psicóticos, a comorbidade depressiva eleva o risco (Quadro 16.4). A atenção deve se intensificar no período pós-alta, notadamente ao longo do primeiro mês. Pacientes que tinham bom funcionamento pré-mórbido podem sofrer mais por temerem a deterioração mental ou se darem conta das perdas ocasionadas pela doença.

QUADRO 16.4

Fatores de risco em pacientes psicóticos

- Idade jovem
- Estágios iniciais da doença
- Bom desempenho acadêmico ou profissional antes de adoecer
- Boa capacidade intelectual
- Curso crônico, com várias internações
- Consciência dos prejuízos funcionais e afetivos acarretados pela doença
- Medo da deterioração mental
- Períodos de melhora que se seguem às recorrências
- Primeiros dias de internação e primeiro mês após alta hospitalar
- Depressão
- Desesperança
- Agitação e inquietude motora (acatisia)
- Abuso e dependência de substâncias psicoativas
- Morar só
- Baixa adesão ao tratamento
- Comunicação de intenção suicida

Fonte: Haw e colaboradores³³ e Hawton e colaboradores.³⁴

Condições clínicas que causam comprometimento funcional, desfiguração, dor e dependência de cuidados de outrem se associam a maior risco de suicídio. Frequentemente, tais doenças são acompanhadas de depressão, o que levanta a suspeita de que não sejam fatores de risco independentes para o suicídio.³⁵

Uma parcela significativa dos pacientes detectados com episódio depressivo durante a internação continuará deprimida. Em um estudo realizado no HC Unicamp, reavaliamos, após seis meses, 50 pessoas que, durante a internação, estavam deprimidas (*major depression*). Vinte e cinco permaneciam deprimidas, e, na maioria (64%), as ideias suicidas perduravam.³⁶

Muitos dos chamados fatores de proteção contra o suicídio influenciam o desenvolvimento psíquico desde a mais tenra idade; protegem-nos contra várias adversidades, não apenas contra o suicídio (Quadro 16.5). No entanto, quando uma pessoa sofre agudamente a influência de um forte fator de risco, os fatores de proteção perdem relativamente sua força. Estudos populacionais, por exemplo, mostram que a gravidez e o primeiro ano após o parto associam-se a um decréscimo de 3 a 8 vezes nas taxas de suicídio entre as mulheres.³⁵ Em casos individuais, entretanto, depressão e psicose puerperais aumentam o risco. Consultar, a esse respeito, o Capítulo 21.

QUADRO 16.5

Fatores de proteção contra o suicídio

Personalidade e estilo cognitivo

- Flexibilidade cognitiva
- Disposição para buscar ajuda
- Abertura à experiência de outrem
- Habilidade para se comunicar
- Capacidade para fazer boa avaliação da realidade
- Habilidade para solucionar problemas da vida

Estrutura familiar

- Bom relacionamento interpessoal
- Senso de responsabilidade em relação à família
- Crianças pequenas na casa
- Pais atenciosos e consistentes
- Apoio em situações de necessidade

Fatores socioculturais

- Integração e bons relacionamentos em grupos sociais
- Adesão a valores e a normas socialmente compartilhados
- Prática religiosa e outras práticas coletivas (clubes esportivos, grupos culturais)
- Rede social que propicia apoio prático e emocional
- Estar empregado
- Disponibilidade de serviços de saúde mental

Outros

- Gravidez, puerpério
- Boa qualidade de vida
- Regularidade do sono
- Boa relação terapêutica

Uma linha valiosa de ação é o fortalecimento de fatores de proteção que se encontram enfraquecidos ou ausentes. Ao atendermos um adolescente deprimido, solitário, que reside longe de sua família, não só pensamos em diminuir os fatores de risco para o suicídio como também procuramos ajudá-lo a criar uma rede de apoio social que, em situações estressantes, possa lhe trazer ajuda prática e conforto emocional.

A avaliação do risco de suicídio em adolescentes requer alguns cuidados, resumidos no Quadro 16.6.

QUADRO 16.6

Avaliação do risco de suicídio em adolescentes

Adolescentes são mais propensos ao imediatismo e à impulsividade. Ainda não têm plena maturidade emocional e, dessa forma, encontram maior dificuldade para lidar com estresses agudos, como término de relacionamentos, situações de vergonha ou humilhação, rejeição pelo grupo social, fracasso escolar e perda de um ente querido. Tais circunstâncias podem desencadear tentativas de suicídio.

Perfeccionismo e autocrítica exacerbada, problemas na identidade sexual e nos relacionamentos interpessoais, discussões frequentes com os pais, autoridades ou colegas, isolamento social, bem como *bullying* (pessoalmente ou pela internet), são fatores de risco revelados em várias pesquisas com adolescentes.

O suicídio de parentes, de colegas ou de personalidades cultuadas pode se constituir em um modelo de comportamento a ser seguido. Nessa eventualidade, fala-se do caráter de *contágio* (ou de *imitação*) de certos suicídios.

Os sinais listados a seguir servem como alerta para risco de suicídio. Além disso, sinalizam a possível existência de transtornos mentais que se iniciam durante a adolescência ou os primeiros anos da vida adulta, como esquizofrenia, depressão, drogadição e transtorno bipolar:

- Mudanças marcantes na personalidade ou nos hábitos
- Comportamento ansioso, agitado ou deprimido
- Piora do desempenho na escola, no trabalho e em outras atividades que costumava manter
- Afastamento da família e de amigos
- Perda de interesse em atividades de que gostava
- Descuido com a aparência
- Perda ou ganho inusitado de peso
- Mudança no padrão comum de sono
- Comentários autodepreciativos persistentes
- Comentários negativos em relação ao futuro, desesperança
- Disforia marcante (combinação de tristeza, irritabilidade e acessos de raiva)
- Comentários sobre morte, sobre pessoas falecidas e interesse por essa temática
- Doação de pertences que valorizava
- Expressão clara ou velada de querer morrer ou de pôr fim à vida

Fonte: Com base em Hawton e colaboradores.³⁷

3. Estado mental atual

A sistematização do exame do estado mental é abordada no Capítulo 9. Aqui, destacamos alguns estados mentais que se associam ao risco de suicídio.

Psychache e constrição cognitiva. O neologismo *psychache* denomina uma dor intolerável, vivenciada como uma turbulência emocional interminável. É uma sensação angustiante de estar preso em si mesmo, sem encontrar saída. Diante da aparente falta de opções (constrição cognitiva), o suicídio é encarado como única saída, uma forma de cessar a consciência e interromper a dor psíquica.³⁸

Ansiedade, inquietude e insônia podem aumentar o desespero e a ideação suicida. Além da ansiedade, a insônia é outro fator de risco igualmente modificável pelo tratamento.

Impulsividade e agressividade. Atos impensados e explosões de raiva podem aparecer espontaneamente no relato do paciente ou de informantes. O paciente poderá negá-los se a pergunta mencionar termos como “impulsividade” e “agressividade”. É melhor evitá-los inicialmente:

Quando estamos sob muita pressão, podemos fazer coisas sem pensar, algo que, se tivéssemos um pouco mais de tranquilidade naquele momento, faríamos de um jeito diferente. Isso já aconteceu com você? Poderia me dar alguns exemplos?

Desesperança. Alguns estudos mostraram que sentimentos de desesperança, bem como a falta ou o enfraquecimento de razões para viver, associam-se mais fortemente ao suicídio do que o próprio humor deprimido:³⁹

Como está sua expectativa em relação ao futuro? Você tem esperança de que sua situação vá melhorar?

Ao avaliar a desesperança, procure, também, que razões o paciente encontra para viver. Por isso, é importante perguntar: Faz algum plano para o futuro? Na sua visão, quais as boas razões que tem para viver?

Ambivalência é o conflito entre duas forças opostas: o desejo de morrer e o desejo de viver. Não devemos nos valer da ambivalência para denunciar, ao paciente, a incoerência de suas manifestações. Ambivalência é diferente de incerteza; o desejo de morrer coexiste com o desejo de ser resgatado e salvo. Ela nos dá a chance de intervir, aliando-nos ao lado do paciente que quer viver.

Vergonha e vingança. É aconselhável não menosprezar o sentido de expiação de culpa ou de ataque vingador que um suicídio pode representar: a vergonha por um segredo descoberto, falhas e frustração de expectativas, a humilhação sentida diante do abandono. Nesses casos, mesmo na ausência dos principais fatores de risco (transtorno mental, tentativa de suicídio prévia), um contexto insuportável leva à necessidade de fazer alguma coisa definitiva. Considere os seguintes fatores agravantes:

- se a pessoa estiver morando sozinha
- com pouco ou nenhum apoio de amigos e de familiares
- se estiver insistindo desesperadamente em uma reconciliação improvável

- se sua forma de pensar e de agir for do tipo *tudo ou nada*
- se houver história de impulsividade
- se passou a ingerir bebida alcoólica em excesso

4. Intencionalidade suicida

A intencionalidade suicida diz respeito ao desejo e à determinação de pôr fim à vida. De modo geral, consideramos que ela cresce a partir de ideias vagas sobre morrer, geralmente de forma passiva, chegando a planos detalhados de como se matar, incluindo providências tomadas antes da morte e cuidados para evitar eventual salvamento logo após a tentativa de suicídio (Fig. 16.3).

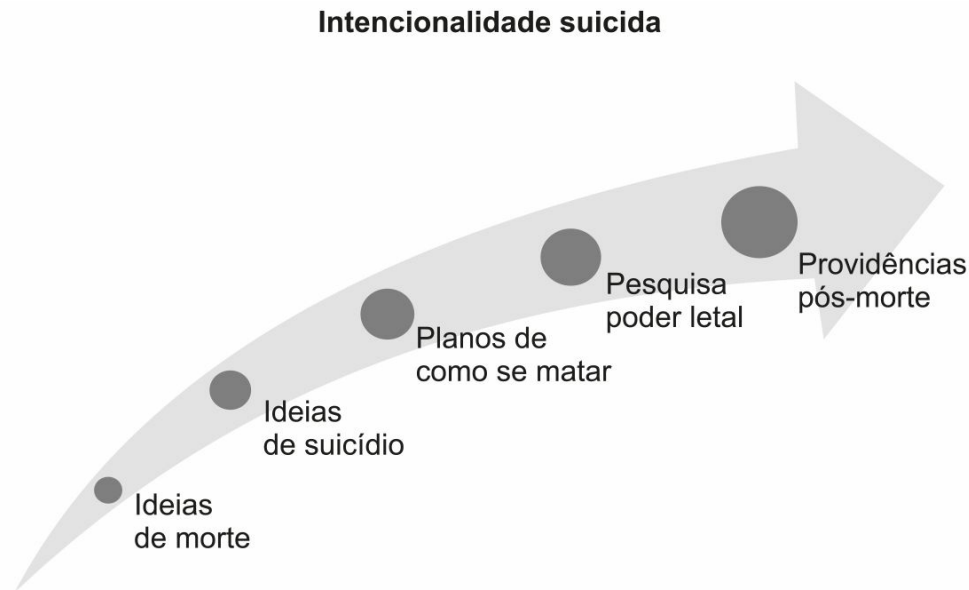


FIGURA 16.3 Características que acompanham o aumento da intencionalidade suicida.

De início, pode ser feita uma pergunta geral sobre o valor dado à vida ou sobre ideias passivas de morte. A seguir, o questionamento sobre suicídio deve ser feito utilizando-se uma linguagem clara e direta. Alguns exemplos são:

Diante das dificuldades que você veio enfrentando, algumas pessoas poderiam pensar que a vida ficou difícil demais. Você chegou a pensar que não vale mais a pena viver?

Você pensa muito sobre morte, sobre pessoas que já morreram ou sobre sua própria morte?

Quando você diz que preferiria estar morto, isso é um desejo de morrer devido a uma doença, por exemplo, ou chega a pensar em suicídio?

Você pensou em suicídio durante essa última semana?

Com frequência, quando o paciente responde afirmativamente à primeira questão sobre ideação suicida, o profissional da saúde busca apaziguá-lo e tenta dissuadi-lo, chegando a mudar de assunto. Nada mais equivocado, pois deve ser seguido um encadeamento de perguntas que partem do mais amplo e que vão se afunilando em detalhes sobre eventual plano suicida (Fig. 16.4).

INTENCIONALIDADE SUICIDA

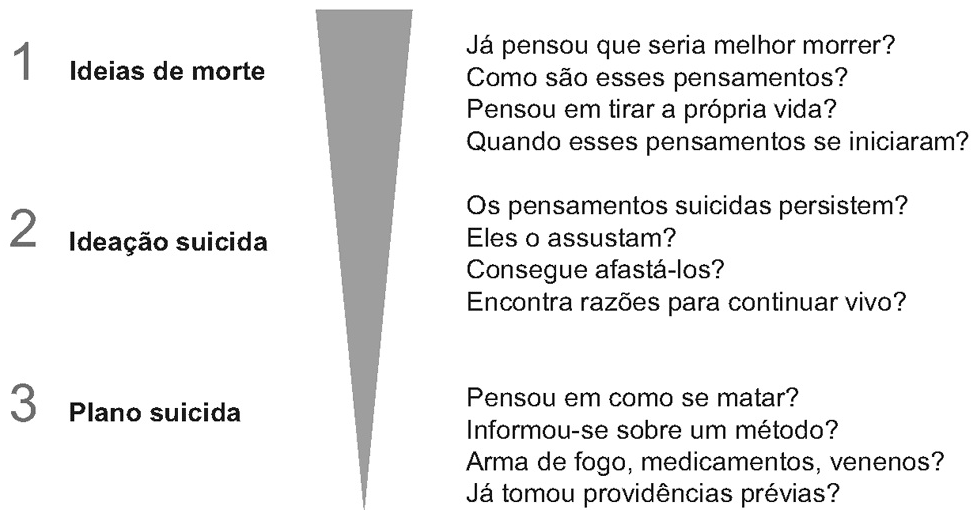


FIGURA 16.4 Sequência de perguntas que investigam o grau de intencionalidade suicida.

A sequência de perguntas indica que estamos interessados em obter informações que se concentrem em três áreas de interesse: presença e natureza das ideias de morte (passivas ou ativas); persistência e intensidade da ideação suicida (e qual o controle que o paciente tem sobre ela); e plano suicida.

De início, a ideação suicida costuma trazer desconforto. A ideia de pôr fim à vida, quando vem em mente, parece perigosa e alheia ao indivíduo, provocando ansiedade. Caso persista na consciência, o indivíduo lutará contra ela. Dizemos, por isso, que a ideação é *egodistônica*. Quando o suicídio passa a ser visto como uma possibilidade de alívio (ideação *egossintônica*), abrem-se as portas para o planejamento de como se matar, o que implica um alto grau de risco.

É por isso que deve haver o detalhamento a respeito dos graus de incômodo e de controle em relação à ideação suicida. Em geral, quanto maior a intensidade, a persistência e a aceitação dos pensamentos suicidas, maior o risco de suicídio.

Perguntar sobre os detalhes de um plano suicida (como, onde e quando) não é curiosidade mórbida; é conduta clínica imprescindível. Nunca se esqueça de questionar sobre a existência e a facilidade de acesso a meios letais, incluindo armas de fogo, venenos, pesticidas agrícolas e medicamentos estocados para uma *overdose*.

Duas condições agravam o risco de suicídio: o fato de o paciente ter se informado sobre o poder letal de um método e o plano de adotar o mesmo recurso empregado por uma pessoa próxima que se matou.

Ao atender pessoas que tentaram o suicídio, devemos nos lembrar de alguns itens da Escala de Intencionalidade Suicida, de Beck e colaboradores,³⁹ que podem ser utilizados na prática clínica (Quadro 16.7). Além disso, o Quadro 16.8 aborda outras nuances da avaliação do risco de suicídio.

QUADRO 16.7

Circunstâncias que sugerem alta intencionalidade suicida

- Comunicação prévia de que iria se matar
- Mensagem ou carta de adeus
- Providências finais antes do ato
- Planejamento detalhado
- Precauções para que o ato não seja descoberto
- Ausência de pessoas por perto que possam socorrer
- Não procurar ajuda logo após a tentativa de suicídio
- Método violento ou uso de drogas mais perigosas
- Crença de que o ato seja irreversível e letal
- Afirmação clara de que queria morrer
- Desapontamento por ter sobrevivido

Fonte: Com base em Beck e colaboradores.³⁹

QUADRO 16.8

Nuanças da avaliação do risco de suicídio

O risco em quadros instáveis. *Delirium*, abuso ou abstinência de substâncias, transtornos da personalidade, estados mistos do transtorno bipolar e depressão ansiosa podem lançar ao suicídio um paciente que, em vários momentos, incluindo o da consulta, parecia tranquilo. Isso implica cautela na formulação do risco de suicídio e no manejo de certas condições clínicas, mesmo quando o paciente nega ideação suicida.

Ocultação das ideias suicidas. Alguns pacientes respondem de forma evasiva; outros, ocultam deliberadamente a intenção suicida. Em certas situações, um clínico experiente poderá ter boas razões para não se basear nas respostas obtidas:

- evidência de quadro psicótico
- paciente evita contato visual durante a entrevista
- incapacidade de estabelecer um contato empático
- paciente aparenta raiva ou distanciamento emocional
- relutância em responder questões sobre ideação suicida
- respostas do tipo “eu não sei”, “sei lá”, etc.

Calma repentina em meio à crise. Deve-se desconfiar das falsas melhoras, especialmente quando situações de crise ainda continuam sem solução ou foram temporariamente apaziguadas pela internação hospitalar. É preciso observar melhor e ficar intrigado com a súbita melhora de uma pessoa que, até há pouco, nos deixava tão preocupados.

Início de recuperação da depressão. O início da recuperação de quadros depressivos é um período crítico. O paciente que volta a ter iniciativa e aumento de energia pode tentar o suicídio. Deve-se lembrar, ainda, que, no início do tratamento com antidepressivos, principalmente em adolescentes, podem surgir pensamentos suicidas.

5. Formulação do risco de suicídio

A formulação do grau de risco de suicídio só é possível após uma avaliação clínica cuidadosa e sistemática. Baseá-la apenas na intuição, após breve entrevista sem informações detalhadas, é temerário. Não custa relembrar que uma formulação de risco não é uma predição sobre quem poderá ou não se matar. Trata-se de um julgamento clínico que permite priorizar as ações dirigidas ao paciente.

O esquema didático da Figura 16.5 reúne de forma ilustrativa alguns parâmetros em três configurações de risco de suicídio.

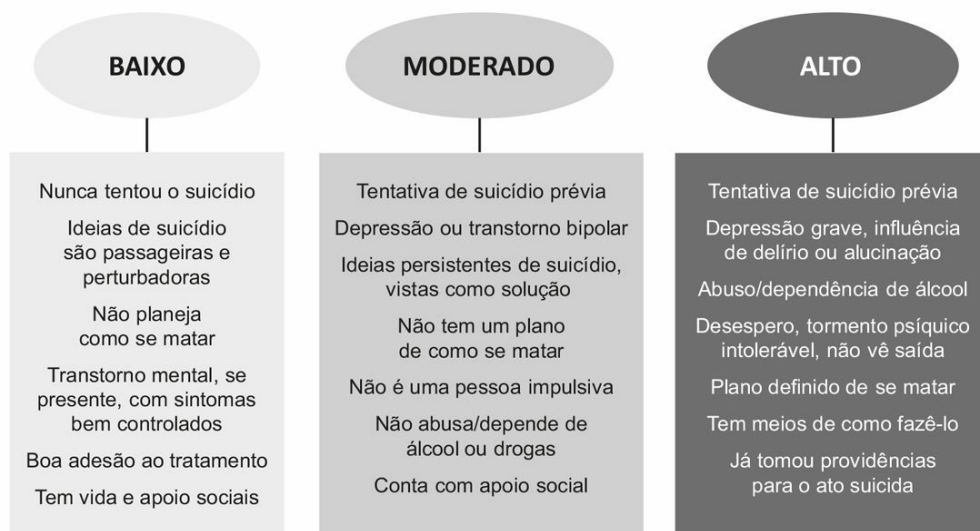


FIGURA 16.5 Esquema didático com três gradações de risco de suicídio.

Não haverá qualquer evidência de que o profissional concluiu a avaliação de risco de suicídio se ele não a registrar no prontuário do paciente. Tal registro deve ser feito em conjunto com as principais medidas terapêuticas e recomendações. Se não for possível fazer ou esclarecer algo, isso também deve constar no registro. A formulação deve ser compartilhada com outros profissionais envolvidos no tratamento.

MANEJO

Aqui, focalizamos o manejo do risco agudo de suicídio. Diretrizes para orientar o manejo de uma modalidade de risco crônico encontram-se no Quadro 16.9. A abordagem psicoterapêutica de pacientes em situações de crise, uma condição muito comum em hospitais gerais, é aprofundada no Capítulo 26.

QUADRO 16.9

Uma modalidade de risco crônico de suicídio

Em certas situações, o gesto ou a ameaça de suicídio parece servir ao objetivo de chamar a atenção e de controlar o ambiente. Isso gera um sentimento de rejeição nas pessoas próximas, que se afastam ou revidam de forma hostil. Fecha-se, desse modo, um círculo vicioso que aprisiona a todos e que precisa ser desfeito.

O que é interpretado como *manipulação* pode até ser um componente do comportamento, mas não o único. Pode haver um transtorno mental subjacente que não foi diagnosticado ou tratado de forma adequada, bem como a influência de condições psicossociais passíveis de intervenção.

A mensagem a ser transmitida a paciente e familiares, em reunião, deve ser: *Sozinho, eu não sou capaz de mantê-lo vivo. Eu posso ajudá-lo, no entanto, a se cuidar melhor, a suportar mais os seus sentimentos e, de alguma forma, se proteger de seus impulsos suicidas. Essa é uma tarefa para todos nós, não apenas para uma pessoa.*

A responsabilidade por um plano de tratamento e pelas ações que visam a sua execução deve ser compartilhada. A mensagem é a de que todos devem assumir algum risco, caso se espere que o paciente desenvolva a capacidade de suportar o agravamento, provavelmente circunstancial e passageiro, de uma tendência suicida recorrente.

A abordagem tem sido usada no tratamento de pacientes que sofrem de transtorno da personalidade *borderline*⁴⁰ e é válida apenas quando se conhece bem o paciente e não houver risco iminente de suicídio. É importante lembrar que pessoas que repetidamente se autoagridem correm maior risco de tentar suicídio.

Os objetivos essenciais do manejo de uma crise suicida são: em curto prazo, manter o paciente seguro, e, em médio prazo, manter o paciente estável. Não se deve passar rapidamente pela simplicidade óbvia dessa afirmação. Ela implica prioridades que não podem ser confundidas.

Quando há risco iminente de suicídio, é preciso manter o paciente a salvo, objetivo para o qual todo o esforço deve se voltar. Ações rápidas e objetivas exigem do profissional disponibilidade e prontidão. Além do estado crítico do paciente, há também familiares atônitos, geralmente tomados por sentimentos contraditórios, que precisarão de esclarecimento e de apoio emocional.

Algumas condições exigem internação psiquiátrica (Quadro 16.10). Caso sejam esgotados os recursos de negociação, uma internação involuntária pode ser necessária. Nesse caso, familiares e autoridade judicial devem ser comunicados.^[NT]

QUADRO 16.10

Circunstâncias que indicam a necessidade de uma internação psiquiátrica

- Estado mental crítico cuja gravidade impeça boa condução ambulatorial
- Exigência de se obter histórico mais acurado ou completo
- Necessidade de um período mais longo de observação do paciente
- Reavaliação do tratamento psiquiátrico que vinha sendo realizado
- Ausência de uma rede de apoio social
- Família claramente disfuncional ou sem condições de dar continência emocional
- Familiares mostram-se cansados de cuidar do paciente

Já no pronto-socorro, deve-se estar atento ao comportamento do paciente e zelar por sua segurança, evitando-se a evasão e o acesso a meios de autoagressão (objetos perfurocortantes, medicamentos, cinto, cadarço de sapato). O paciente deve ocupar um leito de fácil observação

pela enfermagem, que favoreça o monitoramento e, se possível, em andar térreo ou em local com proteção nas janelas. Em casos mais graves, recomenda-se uma pessoa permanentemente ao lado do paciente.

Deve-se enfatizar o risco de suicídio para a equipe assistencial. A atenção deve ser redobrada em alguns períodos, como na troca de turnos da enfermagem, nos passeios no pátio, na licença hospitalar (quando ocorre de um terço a metade dos suicídios de pacientes internados). Os suicídios são mais frequentes na primeira semana de internação e no primeiro mês após a alta hospitalar.⁴¹

A disponibilidade e a capacitação da equipe assistencial são mais importantes do que as barreiras físicas. O diálogo acolhedor e o engajamento do paciente em atividades estruturadas da enfermagem aumentam o sentimento de estar conectado e sendo cuidado. Discussões regulares entre os participantes da equipe assistencial aprimoram a capacidade de lidar com o risco de suicídio.

Psicofármacos devem ser usados tendo-se em mente dois objetivos: reduzir a ativação e a impulsividade do paciente e ajudá-lo a dormir à noite.

Em quadros clínicos em que a estabilidade emocional, a capacidade de julgamento e o autocontrole estejam afetados, a eficácia dos chamados *contratos de não agressão* é questionável. Tal acordo dá, ao clínico e aos familiares, uma falsa sensação de segurança. É imprudente atribuir tanto poder à robustez da aliança terapêutica. É preferível confiar em reavaliações frequentes do risco de suicídio, acompanhadas de ações apropriadas que efetivamente proporcionem segurança.

É inegável que, diante da urgência e da angústia que a intenção suicida impõe, fiquemos tentados a conduzir o paciente para algo assegurador, como uma ideologia ou cuidados extremados de salvamento. No entanto, tais posturas podem resultar no fortalecimento de um aspecto potencialmente letal: a tendência de o paciente transformar uma pessoa – você, no caso – no responsável por sua sobrevivência.

Na mesma linha de pensamento, encorajar um paciente a continuar vivo em nome do tratamento, do terapeuta ou de sua família é reforçar a sensação de que só deva viver por causa dos outros. Esse sentimento mais encoraja do que previne o suicídio.⁴²

Mesmo com todo o cuidado que possamos dispensar, alguns pacientes se suicidam. O suicídio causa um impacto muito grande nos outros pacientes, nos familiares e na equipe assistencial, provocando sentimentos de culpa, raiva e ansiedade. Reuniões com esses grupos de pessoas são importantes para que o ocorrido possa ser discutido e elaborado.

ESTRATÉGIA DE PREVENÇÃO APÓS UMA TENTATIVA DE SUICÍDIO

A prevenção de suicídio pode ser feita por meio de ações específicas direcionadas a determinados grupos da população (Quadro 16.11), tomando-se por base suas condições de saúde e seu grau de risco para o suicídio.^{[NT] 43,44} O Quadro 16.13 reúne algumas estratégias de prevenção, segundo o grau de evidência científica a respeito de sua eficácia.

QUADRO 16.11

Níveis de prevenção, populações-alvo e exemplos de estratégias que podem ser adotadas na prevenção do suicídio

Níveis de prevenção	Universal	Seletiva	Indicada
População-alvo	Público em geral	Grupo com risco moderado	Grupo com alto risco
Exemplos de ações	Restrição de acesso a meios letais Divulgação responsável pela mídia Acesso a serviços de saúde mental e de apoio social	Recursos operacionais e capacitação profissional a fim de melhorar a detecção e o tratamento de transtornos mentais associados ao suicídio	Acompanhamento de pessoas que tentaram o suicídio Apoio a familiares e amigos enlutados

Comumente as pessoas perguntam ao psiquiatra como elas podem ajudar uma pessoa que suspeitam correr risco de suicídio. De modo simplificado, podemos dizer que três passos devem ser dados com o intuito de se prevenir um suicídio (memorize o acrônimo ROC, no Quadro 16.12).

QUADRO 16.12

Três passos para ajudar uma pessoa em risco de suicídio

1. **Risco.** O primeiro passo é própria suspeita do **risco** de uma pessoa vir a se matar. Parece óbvio, mas, às vezes, isso não nos vem à mente. Com sensibilidade, devemos perguntar sobre ideias de morrer, de se matar.
2. **Ouvir.** O segundo passo é **ouvir** com atenção e respeito, sem julgar, recriminar ou se apressar em preleções morais ou religiosas.
3. **Conduzir.** O terceiro passo é **conduzir** a pessoa até um profissional de saúde mental, ou seja, não ficar paralisado. Para quem se encontra fragilizado e sem esperança, a iniciativa de buscar ajuda geralmente não se dá espontaneamente.

QUADRO 16.13

Eficácia de diferentes estratégias de prevenção do suicídio

Muito forte	Forte	Potencialmente benéfico
Restrição de acesso a métodos de suicídio Educação dos responsáveis	Tratamento adequado de doenças mentais Apoio adequado após uma tentativa de suicídio Cobertura discreta pela imprensa de casos de suicídio Treinamento de médicos generalistas Programas escolares baseados na promoção de habilidades sociais Triagem de depressão e de risco de suicídio Centros de aconselhamento em crise Apoio para familiares e amigos enlutados	Controle mais efetivo da ingestão de bebidas alcoólicas Serviços comunitários de saúde mental e de apoio social Educação do público em geral

Dar especial atenção a pessoas que tentaram suicídio é uma estratégia indicada para a prevenção do suicídio. Com o objetivo de testar um programa de incentivo à busca e à manutenção de tratamento, a Organização Mundial da Saúde realizou um ensaio clínico controlado, o Estudo Multicêntrico de Intervenção no Comportamento Suicida – SUPRE-MISS. No Brasil, Campinas foi escolhida como cidade para a execução do projeto.⁴⁸

Foram comparados dois grupos de pessoas atendidas por tentativas de suicídio, sorteadas aleatoriamente para compor duas modalidades de tratamento:

- uma intervenção psicossocial, incluindo entrevista motivacional e telefonemas periódicos, segundo o fluxograma da Figura 16.6 (no momento da alta hospitalar, os pacientes eram encaminhados para um serviço da rede de saúde)
- tratamento comum (apenas um encaminhamento, por ocasião da alta, para um serviço da rede de saúde)

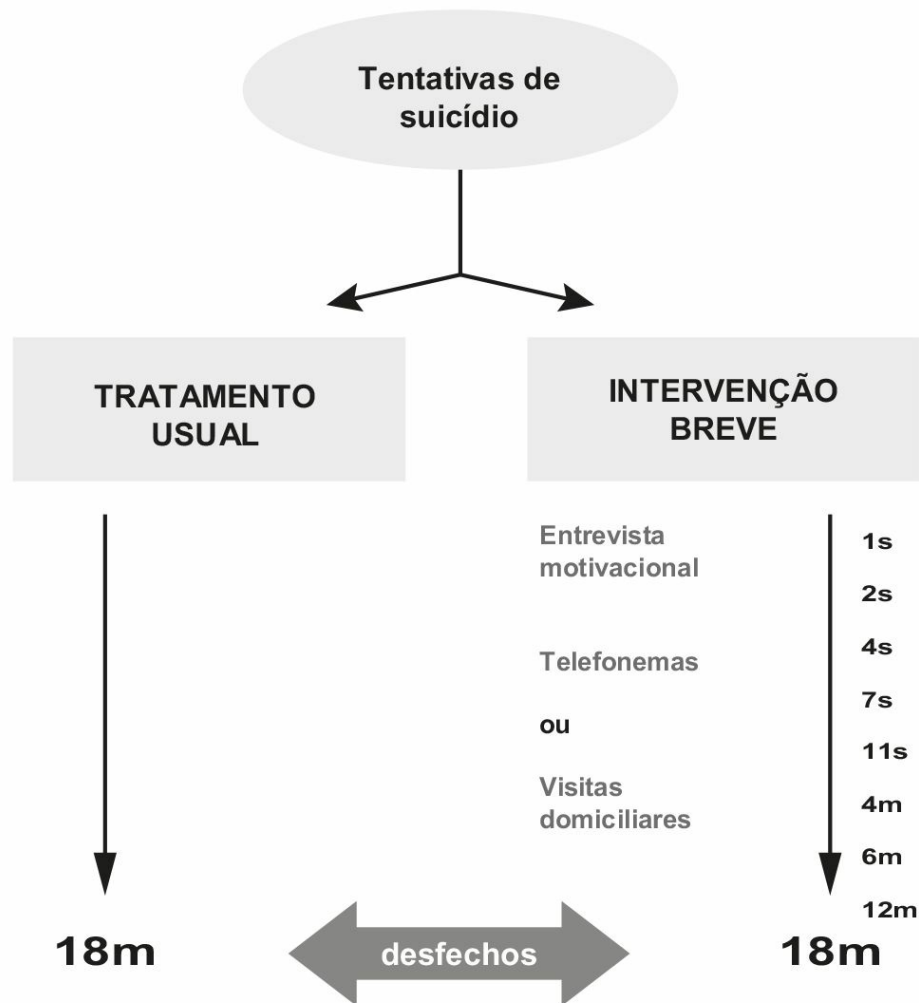


FIGURA 16.6 Fluxograma do ensaio clínico SUPRE-MISS, da OMS.

No total, 2.238 indivíduos participaram do estudo. Na maioria das vezes, o seguimento foi feito por meio de telefonemas periódicos. Ao fim de 18 meses de seguimento, a porcentagem de suicídios no grupo que não recebeu os telefonemas periódicos foi, comparativamente, dez vezes maior (2,2 vs. 0,2%, $p < 0,001$).⁴⁹

A experiência advinda do SUPRE-MISS foi repetida em formato de programa assistencial em alguns municípios brasileiros, com bons resultados. O programa combina a capacitação de profissionais da saúde e o acompanhamento de casos de tentativas de suicídio (Botega et al., 2010c; Cais et al., 2011).^{50,51}

Várias das estratégias de prevenção do suicídio baseiam-se em um profissional que, em dado momento, por estar na porta de entrada do sistema de saúde, estará frente a frente com uma pessoa em crise suicida. Este é um ponto nevrálgico em qualquer planejamento na área de saúde: o profissional que, individualmente, no encontro com o paciente, deverá dar realidade prática aos fluxogramas idealizados pelos gestores das políticas de saúde pública.

Em decorrência do contato mais próximo com as famílias, os profissionais das unidades básicas de saúde e os agentes comunitários de saúde são o primeiro recurso no trabalho de prevenção. Uma relação de proximidade e o conhecimento dos indicativos de risco são essenciais para identificar pessoas potencialmente suicidas.

Feito isso, é preciso haver profissionais capazes e disponíveis para o tratamento de casos mais graves em serviços de saúde mental. Na falta destes, identificar o risco e não ter para onde encaminhar o paciente pode deixar o profissional agustado com sentimentos de desamparo e impotência e com o receio de ser responsabilizado por um suicídio que venha a ocorrer.

REFERÊNCIAS

1. World Health Organization. Preventing suicide: a global imperative. Geneve: WHO; 2014.
2. Minois G. História do suicídio. Lisboa: Teorema; 1998.
3. Costello MM, West DJ, Ramirez B. end-of-life decisions: some international comparisons. *World Health Popul.* 2014;15(2):4-13.
4. Botega NJ. Crise suicida: avaliação e manejo. Porto Alegre: Artmed; 2015.
5. Durkheim E. O suicídio: estudo sociológico. Cidade do Porto: Presença; 1996.
6. Mann JJ. The serotonergic system in mood disorders and suicidal behaviour. *Philos Trans R Soc Lond B Biol Sci.* 2013;368(1615):20120537.
7. Turecki G. The molecular bases of the suicidal brain. *Nat Rev Neurosci.* 2014;15(12):802-16.
8. Hendin H. The psychodynamics of suicide. *Int Rev Psychiatry.* 1992;4(2):157-67.
9. Kohut H. La restauración del sí-mismo. Barcelona: Paidós; 1980.
10. Cassorla RMS, editor. Do suicídio: estudos brasileiros. Campinas: Papirus; 1991.
11. Macedo MMK, Werlang BSG. Tentativa de suicídio: o traumático via ato-dor. *Psic: Teor Pesq.* 2007;23(2):185-94.
12. Chiles JA, Strosahl KD. Clinical manual for assessment and treatment of suicidal patients. Washington: APA; 2005.
13. Pollock LR, Williams JMG. Problem-solving in suicide attempters. *Psychol Med.* 2004;34(1):163-7.
14. Waiselfisz JJ. Mapa da violência 2011: os jovens do Brasil. São Paulo: Instituto Sangari; 2011.
15. Marín-León L, Oliveira HB, Botega NJ. Suicide in Brazil, 2004-2010: the importance of small counties. *Rev Panam Salud Publica.* 2012;32(5):351-9.
16. Orellana, JD, Balieiro AA, Fonseca FR, Basta PC, Souza MLP. Spatial-temporal trends and risk of suicide in central Brazil: an ecological study contrasting indigenous and non-indigenous populations. *Rev Bras Psiquiatr.* 2016;38(3):222-30.
17. Lovisi GM, Santos AS, Legay L, Abelha L, Valencia E. Análise epidemiológica do suicídio no Brasil entre 1980 e 2006. *Rev Bras Psiquiatria.* 2009;31(Suplemento):86-93.
18. Bertolote JM, Fleischmann A, De Leo D, Bolhari J, Botega N, De Silva D, et al. Suicide attempts, plans, and ideation in culturally diverse sites: the WHO SUPRE-MISS community survey. *Psychol Med.* 2005;35(10):1457-65.
19. Nock MK, Borges G, Bromet EJ, Alonso J, Angermeyer M, Beuatrais A. Cross-national prevalence and risk factors for suicidal ideation, plans and attempts. *Brit J Psychiatry.* 2008;192(2):98-105.
20. Botega NJ, Marín-León L, Oliveira HB, Barros MB, Silva VF, Dalgalarrrondo P. Prevalências de ideação, planos e tentativas de suicídio: um inquérito populacional em Campinas SP. *Cad Saúde Pública* 2009;25(12):2632-8.

21. Ores LC, Quevedo LA, Jansen K, Carvalho AB, Cardoso TA, Souza LDM, et al. Risco de suicídio e comportamentos de risco à saúde em jovens de 18 a 24 anos: um estudo descritivo. *Cad Saúde Pública*. 2012;28(2):305-12.
22. Tishler CL, Reiss NS. Inpatient suicide: preventing a common sentinel event. *Gen Hosp Psychiatry*. 2009;31(2):103-9.
23. Botega NJ, Azevedo RCS, Mauro MLF, Mitsuushi GN, Fanger PC, Lima DD, et al. Factors associated with suicide ideation among medically and surgically hospitalized patients. *Gen Hosp Psychiatry*. 2010;32(4):396-400.
24. Botega NJ, Mitsuushi GN, Azevedo RC, Lima DD, Fanger PC, Mauro ML, et al. Depression, alcohol use disorders and nicotine dependence among patients at a general hospital. *Rev Bras Psiquiatr*. 2010;32(3):250-6.
25. Mòscicki EK. Identification of suicide risk factors using epidemiologic studies. *Psychiatr Clin North Am*. 1997;20(3):499-517.
26. Ferreira AD, Sponholz A Jr, Mantovani C, Pazin-Filho A, Passos AD, Botega NJ, et al. Clinical features, psychiatric assessment, and longitudinal outcome of suicide attempters admitted to a tertiary emergency hospital. *Arch Suicide Res*. 2016;20(2):191-204.
27. Cais CFS, Stefanello S, Mauro MLF, Freitas GVS, Botega NJ. Factors associated with repeated suicide attempts: preliminary results of the WHO Multisite Intervention Study on Suicidal Behavior (SUPRE-MISS) from Campinas, Brazil. *Crisis*. 2009;30(2):73-8.
28. Victor SE, Klonsky ED. Correlates of suicide attempts among self-injurers: a meta-analysis. *Clin Psychol Rev*. 2014;34(4):282-97.
29. Beghi M, Rosenbaum JF, Cerri C, Cornaggia CM. Risk factors for fatal and nonfatal repetition of suicide attempts: a literature review. *Neuropsychiatr Dis Treat*. 2013;9:1725-36.
30. Chesney E, Goodwin GM, Fazel S. Risks of all-cause and suicide mortality in mental disorders: a meta-review. *World Psychiatry*. 2014;13(2):153-60.
31. Bostwick JM, Rackley SJ. Completed suicide in medical/surgical patients: who is at risk? *Curr Psychiatry Rep*. 2007;9(3):242-6.
32. Vidal CEL, Gontijo ECM, Lima LA. Tentativas de suicídio: fatores prognósticos e estimativa do excesso de mortalidade. *Cad Saúde Publica*. 2013;29(1):175-87.
33. Haw C, Hawton K, Sutton L, Sinclair J, Deeks J. Schizophrenia and deliberate self-harm: a systematic review of risk factors. *Suicide Life Threat Behav*. 2005;35(1):50-62.
34. Hawton K, Sutton L, Haw C, Sinclair J, Deeks JJ. Schizophrenia and suicide: systematic review of risk factors. *Br J Psychiatry*. 2005;187:9-20.
35. Harris EC, Barraclough BM. Suicide as an outcome for medical disorders. *Medicine*. 1994;73(6):281-96.
36. Gaspar KC, dos Santos A Jr, de Azevedo RC, Mauro ML, Botega NJ. Depression in general hospital inpatients: challenges for consultation-liaison psychiatry. *Rev Bras Psiquiatr*. 2011;33(3):305-7.
37. Hawton K, Saunders KEA, O'Connor RC. Self-harm and suicide in adolescents. *Lancet*. 2012;379(9834):2373-82.

38. Shneidman ES. Suicide as psychache: a clinical approach to self-destructive behavior. Northvale: Jason Aronson; 1993.
39. Beck AT, Resnik HLP, Lettieri DJ, editors. The prediction of suicide. Bowie: Charles; 1974.
40. Linehan MM, Dexter-Mazza ET. Terapia comportamental dialética para transtorno de personalidade borderline. In: Barlow DB, editor. Manual clínico dos transtornos psicológicos. Porto Alegre: Artmed; 2009. p. 366-421.
41. Hunt IM, Windfuhr K, Swinson N, Shaw J, Appleby L, Kapur N, et al. Suicide amongst psychiatric in-patients who abscond from ward: a national clinical survey. BMC Psychiatry 2010;10:14.
42. Hendin H, Haas AP, Maltzberger JT, Koestner B, Szanto K. Problems in psychotherapy with suicidal patients. Am J Psychiatry. 2006;163(1):67-72.
43. Mrazek PJ, Raggerty RJ. Reducing risks from mental disorders: frontiers for preventive intervention research. Washington: National Academy; 1994.
44. Mann JJ, Apter A, Bertolote J, Beautrais A, Currier D, Haas A, et al. Suicide prevention strategies: a systematic review. JAMA. 2005;294(16):2064-74.
45. Cvv.org.br [Internet]. CVV; c2015 [capturado em 04 fev. 2017]. Disponível em: <http://cvv.org.br/>.
46. Abeps.org.br [Internet]. Belo Horizonte: ABEPS; c2016 [capturado em 04 fev. 2017]. Disponível em: <http://abeps.org.br/>.
47. Abp.org.br/portal [Internet]. Rio de Janeiro: ABP; c2017 [capturado em 04 fev. 2017]. Disponível em: <http://www.abp.org.br/portal/>.
48. World Health Organization. Multisite intervention study on suicidal behaviors: SUPRE-MISS. Protocol of SUPRE-MISS. Geneva: WHO; 2002.
49. Fleischmann A, Bertolote JM, Wasserman D, De Leo D, Bolhari J, Botega NJ, et al. Effectiveness of brief intervention and contact for suicide attempters: a randomized controlled trial in five countries. Bull World Health Organ. 2008;86(9):703-9.
50. Botega NJ, Silveira IU, Mauro MLF. Telefonemas na crise: percursos e desafios na prevenção do suicídio. Rio de Janeiro: ABP; 2010.
51. Cais CFS, da Silveira IU, Stefanello S, Botega NJ. Suicide prevention training for professionals in the public health network in a large Brazilian city. Arch Suicide Res. 2011;15(4):384-9.
52. Bertolote JM. O suicídio e sua prevenção. São Paulo: Unesp; 2012.

ANEXO

AVALIAÇÃO DO RISCO DE SUICÍDIO

Paciente: Sexo: Idade: Data: Avaliador:

O que está acontecendo?

- ☐ Desencadeante
- ☐ Motivação
- ☐ Significado do morrer

Estado Mental Atual

- | | | |
|---|--|---|
| ☐ Delírio/alucinação | ☐ Incontinência afetiva | ☐ Constrição cognitiva |
| ☐ Depressão | ☐ Instabilidade do humor | ☐ Vergonha/humilhação |
| ☐ Desesperança | ☐ Ansiedade/inquietude | ☐ Insônia |
| ☐ Desespero (<i>psychache</i>) | ☐ Impulsividade/agressividade | ☐ Dor/incapacitação |
| ☐ Colapso existencial | ☐ Raiva | |

Intencionalidade Suicida

IDEIAS DE MORTE	IDEIAS DE SUICÍDIO	TENTATIVA DE SUICÍDIO PRÉVIA	PLANO SUICIDA
			
☐ Passivas	☐ Persistentes	☐ Quantas	☐ Em preparação
☐ Rejeita o suicídio	☐ Intensas	☐ Última	☐ Detalhado
	☐ Incontroláveis	Motivação	☐ Conhece poder letal
	☐ Vistas como alívio	Intencionalidade	☐ Possui os meios letais
	☐ Aceitáveis	Letalidade	☐ Providências

Principais Fatores de Risco

- | | | |
|--|--|--|
| ☐ Transtorno mental | ☐ Suicídio na família | ☐ Acesso a meio letal |
| ☐ Tentativa de suicídio | ☐ Discórdia familiar | ☐ Rigidez cognitiva |
| ☐ Álcool ou outra droga | ☐ Desilusão amorosa | ☐ Perfeccionismo |
| ☐ Abuso físico ou sexual | ☐ Relações conflituosas | ☐ Conflito de identidade |
| ☐ Exposição a um suicídio | ☐ Desemprego | ☐ Dor/incapacidade |
| ☐ Isolamento | ☐ Derrocada financeira | ☐ Alta hospitalar recente |
| ☐ Falta de apoio social | ☐ Desonra | ☐ Não adere a tratamento |

Formulação do Risco e Manejo

- ☐ Risco baixo
- ☐ Risco moderado
- ☐ Risco alto

[risco de suicídio] Em um estudo de coorte retrospectiva que incluiu 807 tentativas de suicídio ocorridas entre 2003 e 2009, na microrregião de Barbacena (MG), houve 12 (1,5%) suicídios. Isso representa uma taxa 15 vezes maior do que a observada na população. Dos casos de suicídio, 60% ocorreram no primeiro ano que se seguiu à tentativa-índice; 90%, no período de dois anos.³²

[comunicados] Pode ocorrer de a internação psiquiátrica inicialmente cogitada não se realizar, por falta de vaga disponível ou porque a família se compromete a cuidar do paciente em casa. Esta última condição é complexa, potencialmente perigosa e desgastante. A internação domiciliar exige bastante dedicação e não isenta o profissional de responsabilidades.⁴

[suicídio] Uma das ações direcionadas ao público em geral é a conscientização sobre a possibilidade de se evitar uma parcela de mortes se nos dispusermos a ouvir e a ajudar pessoas que estão em crise ou que sofrem de certos transtornos mentais. No ano de 2016, a campanha Setembro Amarelo tomou corpo em uma ação conjunta de várias entidades, principalmente do Centro de Valorização da Vida,⁴⁵ da Associação Brasileira de Estudos e Prevenção do Suicídio⁴⁶ e da Associação Brasileira de Psiquiatria.⁴⁷ Prédios públicos foram iluminados de amarelo, e a campanha foi bastante difundida pela imprensa, que, até então, receava reportagens sobre o tema.



Somatização

Luís Fernando Tófoli

Sandra Fortes

Marco Antonio Alves Brasil

Neury José Botega

Há dificuldades, na nosologia psiquiátrica, em enquadrar, nas classificações diagnósticas, pacientes cuja característica comum e principal é a apresentação de queixas somáticas inespecíficas ou difusas em que falta base orgânica definida que as justifique e nos quais os fatores psicológicos são vistos como etiologicamente relevantes. O fenômeno da somatização é ainda muito pouco compreendido, um “ponto cego” da medicina. Desde já, é importante enfatizar que os quadros sindrômicos mais frequentemente associados com o fenômeno da somatização são os transtornos do humor e de ansiedade; que a falta de achados anatomopatológicos que configurem uma alteração orgânica não significa necessariamente ausência de doença orgânica; e que a presença de sintomas inexplicáveis implica cuidado redobrado no diagnóstico. O tratamento é um desafio em que o médico assistente – que, muitas vezes, não é psiquiatra – e o médico psiquiatra têm de trabalhar juntos. Este capítulo aborda o fenômeno da somatização e seus principais subgrupos de pacientes, incluindo os transtornos factícios e a simulação, em que o relato e os achados clínicos são criações voluntárias do paciente.

O FENÔMENO DA SOMATIZAÇÃO

Sintomas somáticos são fenômenos comuns e benignos da vida cotidiana. A maioria das pessoas tem, frequentemente, sensações somáticas que podem ser consideradas “anormais”. Em geral, essas sensações não estão, e nem serão, associadas a alguma doença, tendendo a desaparecer espontaneamente, sem repercutir no sistema de saúde.¹

É importante lembrar que, no período de uma semana, cerca de 60 a 80% das pessoas saudáveis apresentam, pelo menos, uma queixa somática.² Isso quer dizer que todos nós somatizamos em algum momento. No entanto, a frequência com que isso ocorre, a intensidade do estresse que provocou essa manifestação, como os sintomas são vivenciados e suas consequências variam muito.

A somatização pode ser conceituada de diferentes formas, mas, em geral, ela envolve uma maneira de se responder ao estresse.³ Para um grupo de pessoas com características muito diversas, a presença de sintomas físicos sem explicação as leva à busca de auxílio médico e a comprometimento psicossocial em graus também variados. Esses pacientes recebem diferentes nomes, como “somatizadores”, “histéricos”, “funcionais”, “nervosos”, “poliqueixosos”, “com queixas somáticas inexplicáveis ou funcionais”, “piti” e “DNV” (distúrbio neurovegetativo).¹

Na atenção primária, muitas vezes (30-60%), nenhuma doença grave é encontrada para explicar as queixas físicas apresentadas pelos pacientes.⁴ É alta a prevalência de sofrimento emocional, incluindo transtornos de ansiedade e depressivos e outros quadros associados à presença de sintomas somáticos. Tradicionalmente, a apresentação desses transtornos se dá por meio de queixas somáticas.⁵⁻¹¹

A somatização leva a testes laboratoriais desnecessários e dispendiosos, hospitalizações, condutas iatrogênicas, como múltiplas cirurgias, uso abusivo e inadequado de medicamentos, impacto na família e na vida social, incapacitação e redução de renda, entre outras consequências. Pacientes somatizadores têm um custo total com saúde nove vezes maior do que outros pacientes¹² e média de internação hospitalar de até sete dias por mês, em relação à população em geral, cuja média é de 0,5 dia/mês.¹³⁻¹⁷

Os pacientes somatizadores formam um grupo heterogêneo e não se encaixam em uma simples categorização ou explicação. A somatização, portanto, abarca uma ampla gama de fenômenos clínicos (Quadro 17.1) e é mais bem compreendida como um processo, e não como uma entidade clínica. Entretanto, a presença de somatização não exclui a possibilidade de que o paciente também tenha uma doença física concomitante nem garante que ele não desenvolverá problemas orgânicos. O problema dos pacientes somatizadores quase nunca é totalmente psicogênico ou totalmente orgânico, mas, sim, uma complexa combinação de ambos.^{18,19}

QUADRO 17.1

Diagnóstico diferencial da “apresentação” de queixas somáticas

- Reação normal ao estresse

- Doença orgânica
- Transtornos psiquiátricos (depressão, ansiedade, esquizofrenia, abuso de drogas, transtornos psicóticos, síndromes psico-orgânicas, transtornos de sintomas somáticos, transtornos dissociativos, transtorno factício, transtornos da personalidade)
- Simulação

Com base na classificação de Kirmayer e Robbins,²⁰ propomos a seguinte classificação dos pacientes que se queixam de sintomas físicos sem explicação médica, descrita a seguir.

Pacientes com sofrimento emocional inespecífico

Trata-se de casos geralmente agudos, com pouca adesão ao papel de doente, praticamente nenhum ganho secundário estabelecido e pequeno comprometimento social e funcional. O sofrimento emocional dessas pessoas normalmente é de natureza transitória e associado a crises vitais esperadas (adolescência, início da idade reprodutiva, envelhecimento, etc.) ou não (mortes, mudanças de *status* social, fim de relacionamentos, etc.). A importância dos sintomas é justamente indicar sofrimento psicossocial.

Pacientes com transtornos de ansiedade e/ou depressão

Sintomas físicos fazem parte das próprias definições clínicas dos transtornos de ansiedade e depressivos. Eles incluem fadiga, palpitações, dores, dispneia, sudorese de extremidades, entre outras apresentações. Esses transtornos são os quadros mais frequentes na maior parte dos pacientes em serviços de saúde com sintomas inexplicáveis²¹ e são três vezes mais frequentes do que a apresentação diante de sintomas psicológicos.^{5,6,22-24} Entretanto, é importante ter em vista que as queixas psicológicas, com frequência, ficam ocultas pela incapacidade dos médicos de perguntar sobre problemas psicossociais diante de queixas físicas atípicas.²⁵

Somatizadores crônicos

Esses pacientes têm quadros de curso crônico, com duração que costuma ser maior do que seis meses. Tendem a negar associação entre suas queixas e sofrimento psíquico e demonstram adesão ao papel de doente.²⁶ A prevalência de transtornos de ansiedade e depressivos é alta. Em geral, há comorbidade com os transtornos psiquiátricos especificamente ligados a sintomas físicos inexplicáveis, como a conversão^{10,27,28} e as síndromes funcionais, entre as quais fibromialgia, síndrome do colón irritável e cefaleia de tensão.

Pacientes com ansiedade de doença

Esses pacientes, conhecidos classicamente como “hipocondríacos”, reinterpretam, com características de pensamento prevalente ou delirante, sensações somáticas normais como indicadoras de uma patologia grave, geralmente, única, bem definida e letal, como HIV/aids ou câncer. Nos estudos de Kirmayer e Robbins,²⁰ esses pacientes demonstraram ser um grupo

bastante distinto dos outros pacientes somatizadores, com associação com transtornos mentais de maior gravidade, como depressão e transtorno obsessivo-compulsivo.

É importante ressaltar que a presença de uma somatização crônica não deve ser definida apenas por critérios de exclusão (presença de sintomas somáticos não plenamente explicados por doença orgânica, por efeitos diretos de uma substância ou por outro transtorno psiquiátrico), mas também por critérios positivos (p. ex., a angústia e a preocupação intensas do paciente, o caráter inconsistente, difuso, polissintomático, mutante e dramático das queixas, resistência à aceitação de vínculo com aspectos emocionais, ressentimento por não convencer os médicos da natureza física de sua doença, procura incessante de novas opiniões e investigações médicas e reivindicação por mais exames).

As bases neuropsicológicas do fenômeno da somatização e dos quadros dissociativos ainda estão bastante obscuras e indefinidas e não serão objeto de estudo neste capítulo.

Entretanto, fatores de risco psicológicos, familiares e sociais^{10,24,29} já estão bem demonstrados. Destacam-se os seguintes:

- ausência de cuidado afetivo adequado na infância
- história de ter sido vítima de violência (maus-tratos, abuso sexual) – em especial em síndromes de dor crônica, como a fibromialgia e a dor pélvica atípica
- história de submissão e conformismo
- história de doenças físicas frequentes e valorizadas no ambiente familiar
- prevalência aumentada de transtorno da personalidade antissocial na família – especialmente nos quadros mais graves
- padrão psicológico pessoal de grande dependência desde a segunda década de vida
- amplificação somática das sensações corporais, em especial nos quadros de ansiedade de doença

DIAGNÓSTICOS PSIQUIÁTRICOS RELACIONADOS À SOMATIZAÇÃO CRÔNICA

A denominação *transtornos somatoformes* surgiu em 1980, na terceira revisão do *Manual diagnóstico e estatístico de transtornos mentais*, da American Psychiatric Association (DSM-III).³⁰ Permaneceu assim na *Classificação internacional de doenças e problemas relacionados à saúde* (CID-10)³¹ e nas duas classificações subsequentes do DSM, até ser substituída por *transtorno de sintomas somáticos e transtornos relacionados* no DSM-5.³² Sobressai, nesses quadros, a apresentação repetida de sintomas físicos, com solicitações persistentes de investigações médicas. Apesar dos inúmeros achados negativos e da garantia de que ele não sofre de uma doença física, o paciente, em geral, se tranquiliza apenas por um período muito curto. Diferentemente do transtorno factício e da simulação, a produção de sintomas, nos somatizadores, não se encontra sob controle voluntário.

A recente reformulação nosológica no DSM-5^[NT] tem o objetivo de oferecer um quadro clínico mais claro e um manejo clínico mais efetivo.³⁴⁻⁴⁰ Há, no entanto, divergências entre o DSM-5 e os direcionamentos apontados para a futura CID-11. Nossa opção, para este capítulo, é apresentar a nosologia contemporânea mais recente (DSM-5),³² apontando divergências importantes com a CID-10³¹ e o DSM-IV-TR.⁴¹

A Tabela 17.1 mostra as categorias diagnósticas que compõem o grupo principal dos transtornos que apresentam sintomas físicos inexplicáveis em três sistemas classificatórios: DSM-5, CID-10 e DSM-IV-TR.^{31,32,41}

Tabela 17.1

Categorias diagnósticas caracterizadas por sintomas médicos inexplicáveis em três classificações: DSM-5, CID-10 e DSM-IV-TR

DSM-5	CID-10	DSM-IV-TR
Transtorno de sintomas somáticos e transtornos relacionados	Transtornos somatoformes	Transtornos somatoformes
300.82 Transtorno de sintomas somáticos	F45.0 Transtorno de somatização	300.81 Transtorno de somatização
	F45.1 Transtorno somatoforme indiferenciado	300.82 Transtorno somatoforme indiferenciado
	F45.3 Disfunção autonômica somatoforme	—
	F45.4 Transtorno somatoforme doloroso persistente	307 Transtorno doloroso
300.89 Outro transtorno de sintomas somáticos e transtorno relacionado especificado	F45.8 Outros transtornos somatoformes	300.82 Transtorno somatoforme sem outra especificação
300.82 Transtorno de sintomas somáticos e transtorno relacionado não especificado	F45.9 Transtorno somatoforme sem especificação	
300.7 Transtorno de ansiedade de doença	F45.2 Transtorno hipocondríaco	300.7 Hipocondria
	F45.22 Dismorfofobia	300.7 Transtorno dismórfico corporal
300.11 Transtorno conversivo (transtorno de sintomas neurológicos funcionais)	Transtornos dissociativos (de conversão)	300.11 Transtorno de conversão
	Transtornos dissociativos motores (F44.4), convulsões dissociativas (F44.5) e anestésias dissociativas (F44.6)	
Transtornos dissociativos	—	Transtornos dissociativos
300.14 Transtorno dissociativo de identidade		Transtorno dissociativo de identidade (300.14)

300.12 Amnésia dissociativa	F44.0 Amnésia dissociativa	300.12 Amnésia dissociativa
300.13 Fuga dissociativa	F44.1 Fuga dissociativa	300.13 Fuga dissociativa
300.6 Transtorno de despersonalização/desrealização	F48 Síndrome de despersonalização-desrealização*	300.6 Transtorno de despersonalização
300.15 Outro transtorno dissociativo especificado	F44.2 Estupor dissociativo	300.15 Transtorno dissociativo sem outra especificação
	F44.3 Transtorno de transe e possessão	
	F44.8 Outro transtorno dissociativo	
300.15 Transtorno dissociativo não especificado	F44.9 Transtorno dissociativo não especificado	

* Classificado no DSM-5 dentro dos transtornos obsessivos e relacionados;

** classificado na CID-10 dentro de outros transtornos neuróticos.

Fonte: Organização Mundial da Saúde,³¹ American Psychiatric Association.^{32,41}

Transtorno de sintomas somáticos

Esse diagnóstico do DSM-5 é uma inovação baseada nas evidências de que a excessiva especificação de quadros presentes no DSM-IV-TR, e ainda existentes na CID-10, não tem base empírica e não levou a melhor atenção aos pacientes que têm sintomas inexplicáveis. A categoria diagnóstica gerou certa polêmica⁴² e engloba os seguintes quadros, que fazem parte da CID-10: transtorno de somatização, transtorno somatoforme indiferenciado, disfunção autonômica somatoforme e transtorno somatoforme doloroso persistente.

O diagnóstico geral de transtorno de sintomas somáticos é caracterizado pela presença de um ou mais sintomas que perturbam o paciente ou impactam negativamente sua vida cotidiana. Esses sintomas levam a pensamentos, sentimentos ou comportamentos que causam pensamentos persistentes sobre a gravidade da situação de saúde, ansiedade sobre saúde e excessivo investimento de energia em preocupações com a saúde. Pelo menos um dos sintomas físicos precisa ser persistente (em geral mais do que seis meses).

Transtorno de ansiedade de doença (DSM-5) ou transtorno hipocondríaco (CID-10)

O indivíduo acredita que sofre ou pode vir a sofrer de uma doença física grave. Ele passa a ter preocupações persistentes e interesse incomum pelo próprio corpo. Permanece excessivamente atento às sensações corporais, interpretando-as como sinais de que sofre de câncer, HIV/aids, doenças cardíacas ou outras doenças graves. Diferentemente do transtorno de sintomas somáticos, a relação de prevalência entre os sexos na hipocondria é igual, e não há evidências de tendência familiar.

Ainda não se sabe se a ansiedade de doença é mais bem entendida como um transtorno da percepção corporal e uma alteração de interpretação cognitiva (i.e., a maneira de perceber ou pensar sobre doença) ou, fundamentalmente, como um transtorno de ansiedade ou de “reação de alarme excessiva”, no qual o medo de doença é apenas um dos vários medos presentes.⁴³

Os delírios hipocondríacos podem estar presentes na síndrome psicótica, incluindo esquizofrenia e demência. Quando ocorrem em um transtorno depressivo, são, via de regra,

secundários ao transtorno do humor e estão relacionados com ideias de pessimismo e de morte.

Dismorfofobia ou transtorno dismórfico corporal

Observam-se preocupações excessivas com o “desfiguramento” de partes corporais, em geral da face (nariz, orelhas, boca), ou, com menos frequência, queixas relacionadas aos cabelos, seios e genitália. Esse quadro é acompanhado por grande desconforto emocional e comprometimento do funcionamento social e ocupacional. O início é tipicamente na adolescência, mas varia em uma faixa de idade que vai dos 6 aos 33 anos de idade. O curso é crônico, com intervalos de ausência de sintomas. A recorrência a diversos serviços e a submissão a procedimentos diagnósticos traumáticos tornam-se habituais. A insistência em cirurgias estéticas, em casos em que a deformidade física não é tão marcante, indica a necessidade de avaliação psicológica. Originalmente compreendido como um transtorno “somatoforme”, o transtorno dismórfico corporal hoje é classificado, no DSM-5, como correlato do transtorno obsessivo-compulsivo.

Outros transtornos somatoformes/de sintomas somáticos

Esse diagnóstico é usado para pacientes com sintomas somatoformes que não se enquadram em nenhum dos diagnósticos para os transtornos somatoformes específicos, como sensações de inchaço, de movimentos sobre a pele e parestesias (formigamento e/ou dormência), *globus hystericus* (uma sensação de um caroço na garganta causando disfagia) e outras formas de disfagia.^{31,44}

TRANSTORNOS DISSOCIATIVOS (E CONVERSIVOS)

Tradicionalmente, ao se falar em sintomas neurológicos sem etiologia orgânica, usa-se o termo “transtorno conversivo histérico”. O termo “histeria”, de uso consagrado na prática clínica, é evitado pela CID-10 e pelos DSM a partir de sua terceira edição³⁰ devido a seus vários significados.³¹ O termo “conversão” vem da ideia de que o afeto, não se expressando pela via normal, seria “convertido” no corpo. No DSM-5,³² mantendo a tendência das versões anteriores, os quadros conversivos foram mantidos entre os transtornos de sintomas somáticos com o nome de *transtorno conversivo*, tendo, entre parênteses, a expressão “transtorno de sintomas neurológicos funcionais” (Tab. 17.1). A CID-10 compreende os quadros conversivos junto com os demais quadros dissociativos, em uma grande categoria chamada *transtornos dissociativos* (conversivos).^[INT]

Nos transtornos “conversivos”, verifica-se uma alteração funcional na motricidade e/ou sensibilidade do paciente, sem que haja um comprometimento anatômico que a justifique e voluntariedade do paciente na produção dos sintomas. As manifestações motoras mais frequentes são paresias flácidas e rígidas, contrações, tremores, crises pseudoepilépticas, tiques, alterações da marcha. Entre os sintomas sensoriais, encontram-se distúrbios visuais, parestesias, hiperestesias e anestésias. Apesar dos sintomas, com frequência, o paciente pode se apresentar calmo e indiferente. O clínico descobre que a manifestação não guarda correlação com os conhecimentos anatomopatológicos.

É dado de anamnese importante a ocorrência de um evento desfavorável recente desencadeando ou piorando o episódio conversivo. Uma doença que o paciente teve no passado pode ser a fonte de sintomas conversivos que, no presente, servem para resgatar o paciente de uma situação de estresse. Outra possibilidade é que os sintomas se pareçam com os vivenciados por figuras de identidade ou que tenham sido observados em outras pessoas em situações de estresse intenso e repentino.⁴⁵

Os quadros dissociativos de sintomas neurológicos ainda são vistos nos serviços de emergência, embora com menos frequência. É crucial ao profissional da saúde constatar que não há intencionalidade para produzir o sintoma, a fim de evitar atitudes repressoras ou desprezo lamentável. Torna-se, portanto, imprescindível o diagnóstico diferencial em relação à simulação, assim como a diversas doenças sistêmicas.

Para fazer o diagnóstico, o médico necessita examinar com cuidado o paciente, observando-o sem que ele perceba. Poderá, assim, surpreender movimentos em uma perna “paralisada” e terá de considerar, nesse caso, o diagnóstico diferencial de simulação. Às vezes, os sintomas mantêm-se apenas para determinada atividade. Por exemplo, um paciente que não consegue movimentar as pernas para andar é capaz de cruzá-las durante a entrevista.

A avaliação clínica deve ser cuidadosa, pois, em 5 a 10% dos casos, descobre-se, no seguimento, alguma patologia orgânica que justifica, retrospectivamente, os sintomas “conversivos”.⁴⁶ Às vezes, o diagnóstico diferencial é mais difícil. Crises pseudoepilépticas, por exemplo, com frequência se associam a crises epiléticas verdadeiras, como se aborda no Capítulo 13. A distinção pode ser difícil, notadamente quando não há alterações específicas no

eletrencefalograma (EEG). A causa mais frequente de morbidade e morte nos casos de pseudocrises é o diagnóstico errôneo de epilepsia, resultando em um tratamento agressivo com anticonvulsivantes.³

O termo “dissociação histérica” tem sido utilizado para situações de perda ou distorção de funções neurológicas superiores – em geral, o nível de consciência – na ausência de patologia orgânica. Tanto o DSM-5 quanto a CID-10 referem-se a transtornos dissociativos (Tab. 17.1). Quadros de amnésia e fuga dissociativas são, geralmente, relacionados seletivamente a um evento traumático. Pode haver, também, perda do sentido de identidade, com esquecimento de nome, idade, endereço, etc. Os quadros de estupor dissociativo, em geral associados a eventos traumáticos, precisam ser diferenciados da catatonia psicótica e do estupor depressivo.

Outros quadros dissociativos que envolvem alterações na percepção de identidade, como os transtornos de transe e possessão e os transtornos dissociativos de identidade, são mais levados a cuidados psiquiátricos do que a serviços gerais. É importante ter em mente que a combinação de sintomas dissociativos de amnésia, fuga, transe, possessão e de identidade é muito comum.

Do ponto de vista psicodinâmico, entende-se que a conversão é um “grito” do corpo, quando a mente silencia, ou seja, a dissociação é um silêncio. Visa à elisão de eventos e conflitos, uma “queima de arquivos comprometedores”.⁴⁷ Às vezes, ocorre de o médico intuir a dimensão simbólica de certos sintomas, ligando-os a um conflito na vida do paciente.

Com o sintoma, há o chamado *ganho secundário*, visto que a pessoa pode conseguir reorganizar, temporariamente, as relações desfavoráveis que experimentava com o meio. O *ganho primário* seria a defesa contra a grande ansiedade gerada a partir de uma situação conflitiva, permitindo a descompressão psicológica. Via de regra, são pacientes com características de imaturidade, teatralidade e sugestibilidade.

SÍNDROMES FUNCIONAIS

Apesar de se constituírem em entidades nosológicas claramente descritas, as síndromes funcionais ainda não têm alterações anatomopatológicas bem definidas. Podemos citar como exemplos a síndrome da fadiga crônica, a fibromialgia, a síndrome do cólon irritável e vários tipos de dores, como a torácica, a pélvica atípica e as cefaleias de tensão. O diagnóstico, como no caso dos transtornos psiquiátricos, depende de critérios consensuais, descrição de sintomas e curso da doença.⁴⁸

Há uma superposição de sintomas entre várias dessas síndromes. Por exemplo, uma porcentagem importante de pacientes com fibromialgia queixa-se de cansaço, diarreia ou cefaleia de tensão. O fato de um paciente ser assim diagnosticado depende, em muitos casos, do especialista que o avalia e de os sintomas serem colocados no domínio físico ou psiquiátrico. É grande a comorbidade com transtornos psiquiátricos que demandam tratamento específico.^{24,49-}

⁵¹Uma considerável parcela dos estudiosos dessas síndromes pensa que elas são manifestações variáveis de um mesmo traço basal que leva à tendência a vivenciar sintomas físicos desconfortáveis de maneira crônica e moldada pelo sistema de saúde.

As síndromes funcionais, com frequência, se associam à somatização e a outros transtornos mentais, como transtornos de ansiedade e depressivos. Isso esbarra na resistência dos pacientes que entendem que uma etiologia psíquica não os legitima como doentes. Ademais, a maioria dos médicos especialistas (que são os que efetivamente mais veem síndromes disfuncionais) desconhece as novas categorias psiquiátricas de somatização.

TRANSTORNOS FACTÍCIOS

Os transtornos factícios devem ser diferenciados de outros quadros somáticos. “Factício” significa forçado ou artificial, o que é produzido ou imitado. Vem do verbo latino *facere*, fazer. O paciente “faz” sua doença física ou mental. Há necessidade de se apresentar como doente, de ser atendido e internado. Nada é mais incômodo para o médico, que espera como comportamento habitual de seus doentes o desejo de se tratar e curar-se.

O transtorno factício ocorre tanto na infância e na adolescência quanto na vida adulta. A maioria dos casos é de mulheres jovens, sendo que muitos pacientes tiveram algum contato com profissões da área da saúde. Pode haver lesões autoprovocadas na pele (escoriações, queimaduras, abscessos, impedimento de cicatrização de ferida, etc.), vômitos, além de indução de infecções e febre (injeção de material contaminado no próprio corpo, adição de fezes na urina, aquecimento de termômetro), anemia (retirada de sangue com seringa, indução de hemorragia), hipertireoidismo e hipoglicemia (injeção de insulina ou ingestão de sulfonilureias) e adição de sangue em líquidos corporais coletados para exame.¹²

Pode haver a inclusão de sintomas e sinais psiquiátricos, como, por exemplo, ideação suicida. As lesões e os relatos factícios podem ser provocados por terceiros, geralmente a mãe a uma criança. Essa condição é chamada de transtorno factício por procuração e é abordada no Capítulo 11, sobre interconsulta de crianças.

Chamam a atenção os expedientes criados para falsear resultados de exames e conseguir cirurgias, assim como o bom domínio do vocabulário médico. O relato da anamnese é colorido de matizes, mas, ao mesmo tempo, vago e inconsistente ante a solicitação de pormenores aos quais o paciente não se encontra preparado para responder.⁵²

A motivação para esses comportamentos é obscura, parecendo haver a procura de relações íntimas e gratificantes com as pessoas do meio, sobretudo médicos e enfermeiros. Os pacientes têm pouco ou nenhum *insight* sobre as motivações de sua tendência autodestrutiva. São frequentes alguns traços de personalidade, como imaturidade, dependência, passividade, masoquismo e histrionismo, além de transtorno da personalidade *borderline*.¹²

O psiquiatra pode ser convocado para uma interconsulta quando há apenas suspeita de transtorno factício.⁴⁵ Será preciso ser cauteloso e acalmar a equipe assistencial, que, sentindo-se humilhada pelo paciente, poderá estar “arquitetando vingança”, em uma “cerimônia de desmascaramento”.

A confrontação deve ser feita de modo não acusatório e não punitivo, de preferência pelo médico assistente, sozinho ou com o psiquiatra, reconhecendo o longo sofrimento do paciente. Não se deve insistir na confissão de simulação. O mais importante é o médico passar a certeza de que já está convencido de que o paciente necessita de ajuda psicológica. Quanto mais grave o quadro clínico e mais indignado mostrar-se o médico, mais veemente será a recusa do paciente em aceitar ajuda. O tratamento é difícil, pois implica mudança profunda no modo de ser do paciente, além da reconstrução de um mundo de relações. A abordagem psicoterápica deve envolver o paciente e pessoas do universo familiar para reorganizarem as relações estabelecidas.

Não obstante suas características peculiares, os transtornos factícios são classificados no DSM-5 dentro dos transtornos de sintomas somáticos e relacionados. Na CID-10, eles estão classificados em categoria pouco específica: outros transtornos de personalidade.

Simulação consciente

O transtorno factício diferencia-se das somatizações crônicas e dos sintomas neurológicos dissociativos, pois ele se encontra sob controle voluntário do paciente. Na dissociação, não há o propósito consciente de enganar o médico ou de auferir vantagens. Distingue-se, também, da simulação, na qual o paciente cria ou exagera um transtorno, com a intenção óbvia de evitar certas situações, como uma prova escolar, serviço militar ou processos judiciais.

Poderíamos dizer que na simulação o paciente tem um “bom motivo” para a mentira. Algumas condições que podem ajudar o médico a desconfiar de simulação são: contexto médico-legal (espera de julgamento, solicitação de advogados), discrepância entre queixas e achados objetivos, falta de cooperação com o avaliador e presença de transtorno da personalidade antissocial.⁴⁵

DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL

As perguntas que se deve ter em mente diante de um paciente tomado como somatizador são:

- Que doença orgânica, ainda não diagnosticada, poderia estar causando esses sintomas?
- Que doença psiquiátrica poderia estar causando ou estar associada ao quadro clínico?

O mais relevante, porém, é evitar adotar uma posição de exclusão, ou seja, a de que um diagnóstico exclui o outro. Pacientes com sintomas inexplicáveis podem ter doenças somáticas, e somatizadores podem também deprimir, por exemplo.

É importante lembrar que algumas doenças sistêmicas podem ser confundidas com somatizações, sobretudo em sua fase inicial, como lúpus eritematoso sistêmico, esclerose múltipla, sífilis terciária, tumor cerebral, hiperparatireoidismo, hipertireoidismo, porfiria aguda intermitente, *miastenia gravis* e sarcoidose. Entretanto, um paciente com sintomas inexplicáveis tem a mesma chance de qualquer outra pessoa de sua idade de desenvolver transtornos físicos independentes. Em geral, a boa interação com o paciente, adicionada à anamnese, ao exame físico e aos exames complementares, é capaz de dar conta e dirimir a maioria das dúvidas diagnósticas.

Deve-se lembrar que depressão com sintomas somáticos é muito mais frequente do que os aqui descritos como transtornos de sintomas somáticos inexplicáveis. Pessoas com depressão podem ter queixas somáticas, mais comumente fadiga, inapetência, perda de peso, insônia, distúrbios gastrintestinais ou dores inexplicáveis em várias partes do corpo.²⁸

O início da depressão com sintomas somáticos é comum no idoso. Não é raro que a queixa principal se detenha em dores ou sensações desconfortáveis, como “queimação” pelo corpo, “peso no estômago” ou “gosto ruim na boca”. A anamnese cuidadosa encontrará outros componentes de um quadro que já foi chamado de “depressão mascarada”, sobretudo tendência ao isolamento, pouco prazer ao participar das conversas ou de atividades que antes eram prazerosas, irritabilidade e emagrecimento. O Capítulo 15 se aprofunda nessa temática. As queixas somáticas dos transtornos depressivos estão limitadas aos períodos de humor depressivo. O paciente deprimido está desanimado e não “exige” do médico um medicamento. Já os pacientes com quadros mais graves de sintomas somáticos inexplicáveis têm queixas físicas recorrentes na maior parte de sua vida, independentemente de seu estado de humor, e reivindicam tratamento. Os antidepressivos com características analgésicas, como a amitriptilina e a duloxetine, dão resposta moderadamente satisfatória em quadros dolorosos de somatização, independentemente do estado de humor.

No Capítulo 18, sobre ansiedade e insônia, lembramos que o transtorno de ansiedade generalizada se associa a queixas físicas, incluindo vários tipos de dor, náuseas, gases, dispneias, desmaios, paralisias, afonias, formigamentos e taquicardia. No entanto, o foco de preocupação do paciente não se limita a tais incômodos. No transtorno de pânico, podem também estar presentes sintomas somáticos múltiplos, mas apenas durante os ataques de pânico. Às vezes, o que encontramos são ataques de pânico, nem sempre típicos – mais prolongados e sem a intensidade e todo o cortejo de sintomas do ataque típico –, associados a queixas somáticas.²⁸

MANEJO DO PACIENTE SOMATIZADOR

Tradicionalmente, o primeiro profissional procurado pelo “somatizador” é o médico clínico, generalista ou não. Este tenta tranquilizar o paciente sobre a ausência de patologia somática (geralmente sem sucesso) e opta por encaminhá-lo, sem uma preparação adequada, ao profissional de saúde mental (indicação que normalmente não é seguida), com alta do serviço clínico. Assim, na maioria das vezes, o paciente se sente desprezado pelo profissional ou até mesmo responsabilizado e acusado de estar inventando a doença. O Quadro 17.2 traz algumas atitudes que dificultam o manejo do paciente.

QUADRO 17.2

Atitudes que pioram o tratamento de pacientes somatizadores

- Dizer “você não tem nada”.
- Preocupar-se excessivamente com a remissão dos sintomas – os pacientes não querem apenas alívio do sintoma; também buscam compreensão.
- Desafiar o paciente – concorde que ele tem um problema.
- Explicar prematuramente que os sintomas são emocionais – em especial nos somatizadores crônicos.
- Solicitar exames por insistência do paciente, sem que haja uma indicação para tanto.
- Diagnósticos orgânicos positivos não vão curar o paciente.

Fonte: Com base em Tófoli e colaboradores.¹

Outra conduta observada com frequência no médico é a ânsia de afastar uma patologia orgânica. O profissional passa a solicitar inúmeros exames complementares e a encaminhar para diversos especialistas. O comportamento somatizador do paciente é, assim, reforçado, e o círculo vicioso se mantém, com iatrogenia e agravamento do quadro clínico.

Qual a proposta terapêutica de abordagem desses pacientes, tanto no nível primário quanto em termos de atendimento especializado de saúde mental, considerando tanto os somatizadores transitórios quanto os de curso mais crônico? A interconsulta pode interligar esses níveis de atenção na capacitação e assessoria aos clínicos, diminuindo o número de exames, encaminhamentos e custos e aumentando a eficiência das intervenções.^{16,53}

O eixo da preocupação deveria se firmar nas abordagens psicoterápicas realizadas pelo clínico geral ou pelo especialista. O desafio torna-se grande pelas lacunas no ensino de técnicas psicoterápicas para o médico geral. Há, também, pequena oferta de atendimentos especializados para fazer frente a essa importante demanda reprimida.

O ideal é que o paciente possa reconhecer os componentes psicossociais de suas queixas; assim, melhor será sua evolução. Grande parte das intervenções é direcionada a aumentar a consciência do paciente somatizador sobre a origem não orgânica de suas aflições, deslocando-o do polo da atribuição puramente somática para a direção da compreensão psicológica dos sintomas.

A escuta ativa

A primeira modificação a ser feita refere-se à valorização da escuta como instrumento terapêutico, com mudanças no estilo da entrevista. Tradicionalmente centrado no “olhar” e no “tocar”, o profissional médico não tem sido treinado e não se sente capaz de utilizar a escuta como instrumento de diagnóstico. Escutar ativamente é fundamental para que se possa perceber e avaliar os aspectos psicossociais do paciente, incluindo a presença de eventos estressantes que possam atuar como desencadeantes ou agravantes de sofrimento mental e estruturar uma visão geral da vida pessoal, familiar e social dos pacientes.

Os pacientes somatizadores mais graves e crônicos costumam reagir mal à abordagem de assuntos pessoais, negando quaisquer problemas, o que reforça o padrão tradicional de trabalho médico. Devem-se evitar confrontos, abordando-se os aspectos psicossociais de forma discreta, em geral ao longo do processo de anamnese. A resistência a falar sobre aspectos subjetivos da vida, a precocidade no surgimento dos sintomas e sua cronicidade e a grave incapacidade funcional são fortes indicadores de transtornos crônicos – e não apenas de somatização como maneira de manifestar sofrimento psíquico (Quadro 17.3).

QUADRO 17.3

Formas de compreender o paciente e de fazê-lo se sentir compreendido

- Analisar a forma do surgimento e da apresentação da queixa: analisando os sintomas associados, dentro de um “dia típico”, e avaliando algumas situações específicas da vida do paciente.
- Responder a pistas emocionais: estar atento a esses sinais frequentemente trazidos pelos pacientes e que permitem o estabelecimento de um vínculo a partir do qual o sofrimento emocional pode ser abordado, elaborado e superado.
- Investigar os antecedentes psicossociais e suas consequências, principalmente em termos de sua associação com o surgimento de transtornos mentais como ansiedade e depressão, e do desencadeamento das queixas somáticas inexplicáveis.
- Pesquisar crenças sobre saúde/agenda do paciente. Entender como o paciente compreende seu processo de adoecer é vital para o manejo correto de suas patologias e problemas.
- Exame físico breve: fazer sempre, pois garante a confiança do paciente pelo fato de que suas queixas não estão sendo desconsideradas, de que se está atento a possíveis problemas físicos, e garante a tranquilidade de não se negligenciar a percepção de possíveis novas alterações físicas que requeiram outra forma de cuidado.

Fonte: Com base em Tófoli e colaboradores.¹

No tratamento dos transtornos conversivos, confrontar o paciente com o “caráter artificial” de seus sintomas não ajuda. É aconselhável um espírito de acolhimento e de confiança, tranquilizando o paciente de que o exame físico e os testes complementares não acusaram uma doença grave. O melhor é dizer que os sintomas melhorarão gradualmente e fazer algumas sugestões de tratamento e do que acontecerá com o passar dos dias. A exemplo da abordagem feita com pacientes somatizadores, é interessante a tentativa de recodificar o sintoma, como descrito mais adiante, explicando que, muitas vezes, nosso corpo reage muito antes que a nossa mente possa dar conta do que está ocorrendo.

Diagnóstico precoce

O diagnóstico precoce é fundamental, não apenas para que o tratamento correto possa ser instituído, mas para que condutas iatrogênicas e que tornem o processo crônico possam ser evitadas. Nesse processo, não apenas instrumentalizar a escuta é fundamental, mas, principalmente, trabalhar com uma concepção multifatorial do adoecer. Há, com grande

frequência, mais de um diagnóstico nosológico – a comorbidade é alta, e uma parte significativa dos pacientes com somatização sofre de transtornos mistos de ansiedade e depressão.²⁷

Recodificando os sintomas

Recodificar os sintomas é associá-los a um sofrimento emocional, levando o paciente a perceber como eles se associam cronologicamente a situações estressantes. Mesmo pacientes mais resistentes costumam aceitar que o “agravamento” do quadro se relaciona às suas emoções. Para o sucesso de uma intervenção médica, é sempre necessário que paciente e médico construam um sistema explicativo em comum para o processo de adoecimento presente. Somente a partir daí pode ser desenvolvida uma aliança terapêutica.⁵⁴

Deve-se lembrar que, além de representar um padrão de comunicação de sofrimento, a somatização pode ser tomada como um mecanismo de defesa que foi reforçado ao longo do tempo. Ao ser submetido a problemas de várias naturezas (estresse, perdas, conflitos), o paciente tende a retornar a esse padrão conhecido de funcionamento.

Encaminhando para a saúde mental

O paciente somatizador precisa de um médico clínico de referência, um “porto seguro”, com quem possa estabelecer um vínculo permanente. Esse médico conhece a evolução das condições de saúde de seu paciente e impedirá intervenções diagnósticas excessivas, sem negar a real possibilidade de o paciente apresentar uma intercorrência clínica no curso de sua vida. É uma reclamação frequente de pacientes somatizadores que, uma vez caracterizados como portadores de patologia mental em geral, e de somatização em particular, suas queixas tendem a ser desconsideradas pelos profissionais da saúde.

A abordagem pelo especialista

É importante estruturar uma proposta de tratamento, com objetivos bastante delimitados.

1. *Estabelecer vínculos terapêuticos estáveis*, fixando o paciente em uma unidade assistencial, onde um profissional de clínica médica e um profissional de saúde mental tornem-se sua referência.
2. *Tratar as intercorrências psiquiátricas*. É frequente a comorbidade psiquiátrica, sendo imprescindível o tratamento específico. Na dor crônica, destaca-se o uso de antidepressivos tricíclicos em baixas doses, principalmente amitriptilina, além dos inibidores de recaptação dual (venlafaxina e duloxetina).
3. *Lidar com os ganhos secundários*. Um dos aspectos que mais dificultam a melhora desses pacientes refere-se aos ganhos secundários. Muitos desses pacientes, periodicamente, têm de se submeter a uma avaliação pericial para o sistema previdenciário. A repetida necessidade de provarem que estão incapacitados para o trabalho reforça intensamente o papel de doente.

Nos pacientes com somatizações crônicas e graves, quer pelo curso crônico, quer por apresentarem quadros mais complexos (principalmente nos casos de hipocondria e dor crônica), a indicação de terapia de grupo se mantém, com reforço da utilização de técnicas cognitivas (Quadro 17.4).

QUADRO 17.4

Intervenções terapêuticas na somatização

Componente	Intervenções possíveis
Experiencial	Técnicas para diminuir sensação somática (p. ex., <i>biofeedback</i> , farmacoterapia para as comorbidades psiquiátricas)
Cognitivo	Reatribuição das sensações devidas a causas ameaçadoras por causas benignas Técnicas de distração
Comportamental	Técnicas operativas para reduzir o consumo de medicamento Visitas regulares ao médico clínico de referência em vez de atendimentos em emergências

Fonte: Abbey e colaboradores.³

A utilização de relaxamento (ver Apêndice do Cap. 26) associada à alteração do modelo cognitivo relacionado à interpretação de sensações corporais, à adesão ao papel de doente, aos comportamentos de evitação e às dificuldades na comunicação com a equipe médica deve ser mais enfatizada.

Embora haja relatos de melhora no desempenho social e de diminuição do tempo dedicado à doença, de modo geral, as perspectivas de melhora são mais modestas nos pacientes mais graves, que acabam abandonando o tratamento. Têm sido propostos tratamentos que empregam técnicas de terapia cognitivo-comportamental e psicoterapia psicodinâmica breve.^{39,55-60}

REFERÊNCIAS

1. Tófoli LF, Fortes S, Gonçalves D, Chazan LF, Ballester D. Somatização e sintomas físicos inexplicáveis para o médico de família e comunidade. In: Programa de Atualização em Medicina de Família e Comunidade. Porto Alegre: Artmed Panamericana; 2007. vol. 2.
2. Kellner R, Sheffield BF. The one-week prevalence of symptoms in neurotic patients and normal. *Am J Psychiatry*. 1973;130(1):102-5.
3. Abbey SE, Wulsin L, Levenson JL. Somatization and somatoform disorders. In: Levenson JL, editor. *The American Psychiatric Publishing textbook of psychosomatic medicine: psychiatric care of the medically III*. 2nd ed. Washington: APA; 2010. p. 261-84.
4. Barsky AJ. The paradox of health. *N Engl J Med*. 1988;318(7):414-8.
5. Bridges KW, Goldberg D. Somatic presentation of DSM III psychiatric disorders in primary care. *J Psychosom Res*. 1985;29(6):563-9.
6. Lobo A, Garcia-Campayo JJ, Larrubia J, Lobo A, Perez -Echeverria MJ, Campos R. Somatisation in primary care in Spain: I. estimates of prevalence and clinical characteristics. *Br J Psychiatry*. 1996;168(3):344-8.
7. Kirmayer LJ, Young A, Robbins JM. Symptom attribution in cultural perspective. *Can J Psych*. 1994;39(10):584-95.
8. Üstün TB, Sartorius N. *Mental illness in general health care: an international study*. Chichester: John Wiley & Sons; 1995.
9. Mari JJ, Iaconi E, Williams P, Simões O, Silva JBT. Detection of psychiatric morbidity in the primary care in Brazil. *Rev Saúde Públ*. 1987;21(6):501-7.
10. Fortes S. transtornos mentais na atenção primária: suas formas de apresentação, perfil nosológico e fatores associados em unidades do programa de saúde da família do município de Petrópolis/ Rio de Janeiro/ Brasil [tese]. Rio de Janeiro: Instituto de Medicina Social, Universidade do Estado do Rio de Janeiro; 2004.
11. Villano LA. Problemas psicológicos e morbidade psiquiátrica em serviços de saúde não psiquiátricos: o ambulatório de clínica geral [tese]. São Paulo: Universidade Federal de São Paulo; 1998.
12. Ford CV. *The somatization disorders: illness as a way of life*. New York: Elsevier; 1983.
13. Katon W. Depression: relationship to somatization and chronic medical illness. *J Clin Psychiatry*. 1984;45(3 Pt 2):4-12.
14. Katon W. Panic disorder and somatization: a review of 55 cases. *Am J Med*. 1984;77(1):101-6.
15. Katon W, Lin E, Von Korff M. Somatization: a spectrum of severity. *Am J Psychiatry*. 1991;148:34-40.
16. Smith GR, Monson RA, Ray DC. Psychiatric consultation in somatization disorder: a randomized controlled study. *N Engl J Med*. 1986;314(22):1407-13.
17. Rundell JR, Wise MG. *Concise guide to consultation psychiatry*. 3rd ed. Washington: APA; 2000.

18. Quill TE. Somatization disorder one of medicine's blind spots. *JAMA*. 1985;254(21):3075-9.
19. Lloyd GG. Psychiatric syndromes with a somatic presentation. *J Psychosom Res*. 1986;30(2):113-20.
20. Kirmayer LJ, Robbins JM. Current concepts of somatization: research and clinical perspectives. Washington: APA; 1991.
21. Ring A, Dowrick CF, Humphris GM, Davies J, Salmon P. What do general practice patients want when they present medically unexplained symptoms, and why do their doctors feel pressurized? *J Psychosom Res*. 2005;59(4):255-60.
22. Garcia-Campayo J, Lobo A, Perez-Echeverria MJ, Campos R. three forms of somatization presenting in primary care settings in Spain. *J Nerv Ment Dis*. 1998;186(9):554-60.
23. Garcia-Campayo J, Sanz-Carrillo J. A review of the differences between somatizing and psychologizing patients in primary care. *Int J Psychiatry Med*. 1999;29(3):337-45.
24. Garcia-Campayo J. Trastornos somatomorfos. Barcelona: SCM; 2002.
25. Salmon P, Ring A, Dowrick CF, Humphris GM. The somatising effect of clinical consultation: what patients and doctors say and do not say when patients present medically unexplained physical symptoms. *Soc Sci Med*. 2005;61(7):1505-15.
26. Pilowsky I. From conversion hysteria to somatisation to abnormal illness behaviour? *J Psychosom Res*. 1996;40(4):345-50.
27. Brasil MAA. Pacientes com queixas difusas: um estudo nosológico de pacientes apresentando queixas somáticas múltiplas e vagas [tese]. Rio de Janeiro: Instituto de Psiquiatria, Universidade Federal do Rio de Janeiro; 1995.
28. Tófoli LF. Investigação categorial e dimensional sobre sintomas físicos e síndromes somatoformes na população geral [tese]. São Paulo: Faculdade de Medicina, Universidade de São Paulo; 2004.
29. Waitzin H, Mangaña H. The black box in somatization: unexplained physical symptoms, culture and narratives of trauma. *Soc Sci Med*. 1997;45(6):811-25.
30. American Psychiatric Association. Diagnostic and statistical manual of mental disorders: DSM-III. 3rd ed. Washington: APA; 1980.
31. Organização Mundial de Saúde. Classificação de transtornos mentais e de comportamento da CID-10: descrições clínicas e diretrizes diagnósticas. Porto Alegre: Artmed; 1993.
32. American Psychiatric Association. Diagnostic and statistical manual of mental disorders: DSM-5. 5th ed. Washington: APA; 2013.
33. World Health Organization. ICD-11 beta draft [Internet]. Geneva: WHO; 2016 [capturado em 12 fev. 2017]. Disponível em: <http://apps.who.int/classifications/icd11/browse/l-m/en>.
34. Kirmayer LJ, Sartorius N. Cultural models and somatic syndromes. *Psychosom Med*. 2007;69(9):832-40.
35. Dimsdale JE, Dantzer R. A biological substrate for somatoform disorders: importance of pathophysiology. *Psychosom Med*. 2007;69(9):850-4.

36. Dimsdale JE, Patel V, Xin Y, Kleinman A. Editorial: somatic presentations - a challenge for DSM-V. *Psychosom Med*. 2007;69(9):829
37. Dimsdale JE, Creed F, Escobar J, Sharpe M, Wulsin L, Barsky A, et al. Somatic symptom disorder: an important change in DSM. *J Psychosom Res*. 2013;75(3):223-8.
38. Noyes R, Stuart SP, Watson DB. A reconceptualization of the somatoform disorders. *Psychosomatics*. 2008;49(1):14-22.
39. Abbass A, Kisely S, Kroenke K. Short-term psychodynamic psychotherapy for somatic disorders. *Psychother Psychosom*. 2009;78(5):265-74.
40. Rief W, Isaac M. The future of somatoform disorders: somatic symptom disorder, bodily distress disorder or functional syndromes? *Curr Opin Psychiatry*. 2014;27(5):315-9.
41. American Psychiatric Association. Diagnostic and statistical manual of mental disorders: DSM-IV-TR. 4th ed. Washington: APA; 1990.
42. Frances A. DSM-5 badly flunks the writing test [Internet]. *Psychiatric Times*; 2013 [capturado em 12 fev. 2017]. Disponível em: <http://www.psychiatrictimes.com/blogs/dsm-5/dsm-5-badly-flunks-writing-test>.
43. Barsky AJ, Barnett MC, Clearly PD. Hypochondriasis and panic disorder: boundary and overlap. *Arch Gen Psychiatry*. 1994;51(11):918-25.
44. Abbey S. Somatization and somatoform disorders. In: Rundell JR, Wise MG, editors. *Textbook of consultation-liaison psychiatry*. Washington: APA; 1996. pp. 368-400.
45. Barsky AJ. Functional somatic symptoms and somatoform disorders. In: Cassem NH, editor. *Massachusetts general hospital handbook of general hospital psychiatry*. Saint Louis: Mosby; 1997. p. 305-36.
46. Taylor RL. *Psychological masquerade: distinguishing psychological from organic disorders*. 3rd ed. New York: Springer; 2007.
47. Ramadam ZBA. Conceito, quadro clínico e classificação dos quadros histéricos. In: Fortes JRA, Filho M, Constantino E, Borge Ali RZ, Vaz de Arruda P, editors. *Psiquiatria e medicina interna*. São Paulo: Astúrias; 1988. p. 20-5.
48. Kanaan RA, Lepine JP, Simon C, Wessely S. the association or otherwise of the functional somatic syndromes. *Psychosom Med*. 2007;69(9):855-9.
49. Wessely S, Nimnuam C, Sharpe M. Functional somatic syndromes: one or many? *Lancet*. 1999;354(9182):936-9.
50. Sharpe M, Carson A. Unexplained somatic symptoms, functional syndromes and somatization: do we need a paradigm shift? *Ann Intern Med*. 2001;134(9):926-30.
51. Brasil MAA, Appolinario JC, Fortes S. Functional somatic syndromes: many names for the same thing? In: Maj M, Akiskal HS, Mezzich JE, Okasha A, editors. *Somatoform disorders: evidence and experience in psychiatry*. New York: John Wiley & Sons; 2005. p. 319-21.
52. Hoirisch A. Simulação no hospital geral. *Cad Psicol Med Psicopatol Psiquiatr*. 1998;1(2).
53. Smith GR, Rost K, Kashner TM. A trial of the effect of a standardized psychiatric consultation on health outcomes and costs in somatizing patients. *Arch Gen Psychiatry*. 1995;52(3):238-43.

54. Helman C. Cultura, saúde e doença. Porto Alegre: Artmed; 1994.
55. Lidberg J. Group therapy for somatization disorders in general practice: effectiveness of a short cognitive-behavioural treatment model. *Acta Psychiatrica Scand.* 1997;96(1):14-24.
56. Allen F. The new somatic symptom disorder in DSM-5 risks mislabeling many people as mentally ill. *BMJ.* 2013;346:f1580.
57. Kashner TM, Rost K, Cohen B, Anderson M, Smith GR. Enhancing the health of somatization disorder patients. Effectiveness of short-term group Therapy. *Psychosomatics.* 1995;36(5):462-70.
58. Longstreth GF, Mason C, Schreiber IG, Tsao-Wei D. Group psychotherapy for women molested in childhood: psychological and somatic symptoms and medical visits. *Int J Group Psychotherapy.* 1998;48(4):533-41.
59. Looper KJ, Kirmayer LJ. Behavioral medicine approaches to somatoform disorders. *J Consult Clin Psychol.* 2002;70(3):810-27.
60. Balon R. Cognitive-behavioral therapy, psychotherapy and psychosocial interventions in the medically ill. *Psychother Psychosom.* 2009;78(5):261-4.

[DSM-5] A CID-11 provavelmente também extinguirá o termo “transtornos somatoformes”.³³

[(conversivos)] Essa tendência deve se manter na CID-11.



Ansiedade e insônia

Catalina Camas Cabrera
Alcion Sponholz Junior

A ansiedade faz parte da vida e é um sentimento intrínseco ao desenvolvimento humano. Além de estar associada às mudanças naturais do desenvolvimento, é um sinal de alerta em caso de perigo iminente. No entanto, quando há resposta inadequada a uma percepção ou um estímulo em razão de sua intensidade ou duração, configura-se a ansiedade patológica.

Este capítulo faz distinção entre a ansiedade normal e a patológica, em particular no contexto do hospital geral, além de apresentar aspectos clinicamente relevantes sobre as manifestações patológicas da ansiedade, as diferentes apresentações clínicas e as diretrizes para seu manejo, incluindo avaliação de situações especiais. Além disso, traz uma breve exposição sobre a fisiologia do sono e seus transtornos, recomendações para a boa avaliação e medidas farmacológicas e não farmacológicas para a superação da insônia.

ANSIEDADE

A ansiedade é uma reação emocional normal e esperada diante de situações novas e desconhecidas. Como sintoma, é encontrada em alta prevalência (18%) na população em geral, sendo queixa bastante comum nos serviços de saúde.

Do nascimento à morte, o ser humano enfrenta o desafio de sobreviver, evoluir e se adaptar. No início da vida, ainda bastante indefeso, começa a perceber sensações e desconfortos que vão se organizando em percepções mais discriminadas de si mesmo, do mundo e das mudanças, e, com a percepção ampliada sobre sua fragilidade ante as ameaças desconhecidas, impõe-se a necessidade da adaptação. Viver é, antes de tudo, adaptar-se, e a adaptação leva a conquistas de recursos e habilidades.

A ansiedade faz parte da vida, é um sentimento intrínseco ao desenvolvimento humano, propulsor de mudanças e experimentado de modo único e pessoal. Quando não é desproporcionalmente intensa, pode melhorar o desempenho global, promover soluções criativas e estimular a cooperação. Além de estar associada às mudanças naturais do desenvolvimento, é um sinal de alerta, sentida como uma ameaça de perigo iminente. É natural, portanto, ante o adoecer, o medo que precede um exame invasivo ou a ansiedade que surge após um comunicado de diagnóstico ou de internação.

Ansiedade patológica

Ansiedade patológica caracteriza-se pela resposta inadequada a uma percepção ou a um estímulo em razão de sua intensidade ou duração. Ela paralisa o indivíduo ou o faz agir de forma caótica, dificultando a adaptação às situações e ao ambiente.

A ansiedade patológica pode surgir em todas as fases da vida e interferir no desenvolvimento, com prejuízo na aquisição de conhecimentos, na autoestima, na socialização, na visão do mundo e de si mesmo (comprometendo planos de vida), além de predispor a maior vulnerabilidade, com perda de defesas físicas e psíquicas (como doença autoimune ou câncer após um grande estresse). O Quadro 18.1 apresenta os sinais e sintomas da ansiedade.

QUADRO 18.1

Sintomas e sinais de ansiedade

Físicos	Psíquicos
▪ Aflição abdominal ▪ Agitação ▪ Aumento de evacuações (diarreia) ▪ Aumento do peristaltismo (cólicas) ▪ Aperto no peito ▪ Boca seca	▪ Agressividade ▪ Angústia ▪ Apreensão ▪ Comportamento regressivo ▪ Despersonalização ▪ Desrealização

- | | |
|-------------------------------------|--|
| ■ Bocejos | ■ Dificuldade de concentração |
| ■ “Bola na garganta” | ■ Diminuição da atenção |
| ■ Calafrios | ■ Diminuição da memória |
| ■ Cefaleia | ■ Diminuição do limiar para dor/desconfortos |
| ■ Contraturas musculares | ■ Diminuição do limiar para tolerância |
| ■ Dor de cabeça (cefaleia) | ■ Evitação de situação/lugar |
| ■ Dor no estômago (epigastria) | ■ Fala acelerada/repetitiva/circunstancial |
| ■ Dor precordial (angina) | ■ Hipervigilância |
| ■ Dores musculares (mialgias) | ■ Ideação suicida |
| ■ Empachamento (distensão) | ■ Impulsividade |
| ■ Enjoo (náuseas) | ■ Inquietação |
| ■ Espasmos | ■ Insegurança |
| ■ Fadiga fácil | ■ Insônia |
| ■ Falta de ar (dispneia) | ■ Irritabilidade |
| ■ Flatulência (gases) | ■ Mal-estar indefinido |
| ■ Formigamentos (parestias) | ■ Mau humor |
| ■ Pupilas contraídas (midríase) | ■ Medo de morte iminente |
| ■ Movimentos bruscos (sobressaltos) | ■ Medo difuso e impreciso |
| ■ Palidez | ■ Sensação de fraqueza |
| ■ Palpitação (taquicardia) | ■ Nervosismo |
| ■ Piloereção | ■ Pânico |
| ■ Micção frequente (polaciúria) | ■ Pensamento acelerado |
| ■ Respiração curta | ■ Preocupações exageradas |
| ■ Somatizações | ■ Sensação de estar ligado/ser elétrico |
| ■ Sufocação | ■ Sensação de estranheza |
| ■ Sudorese fria | ■ Sensação de morte iminente |
| ■ Tensão muscular | ■ Sensação de opressão e desconforto |
| ■ Tonturas | ■ Sentimento de culpa |
| ■ Tremores | ■ Tensão |
| ■ Vômitos | |

É possível distinguir a ansiedade patológica da ansiedade normal em resposta ao estresse por meio de quatro critérios:¹

- **Autonomia:** a ansiedade ocorre sem causa aparente.
- **Intensidade:** elevada, desproporcional. Alto nível de sofrimento ou baixa capacidade de tolerá-lo.
- **Duração:** persistente ou recorrente.
- **Comportamento:** mal-adaptativo, com prejuízo global do funcionamento.

A ansiedade pode ser um sintoma não específico decorrente de causas diversas (p. ex., uso de álcool e drogas), pode estar associada a determinadas situações (ansiedade situacional) ou ser tão constante a ponto de ser considerada um traço de personalidade.

Ansiedade no ambiente hospitalar

A ansiedade é uma resposta temporária normal, esperada diante de estresse e necessária à adaptação e ao enfrentamento de situações inesperadas. Uma ansiedade moderada e situacional habitualmente se resolve com o desaparecimento do fator desencadeante ou com a adaptação do paciente à situação.

A percepção de estar doente é um evento objetivo e também uma experiência pessoal e reflexiva. Certas reações são comuns à experiência de adoecimento, como diminuição do interesse nos outros, fixação da atenção nas percepções corporais, temor quanto ao significado e às consequências dos seus sintomas e desejo de ser apoiado, protegido. Veja, sobre essa temática, o Capítulo 2, “O paciente diante da doença e da hospitalização”.

Alguns pacientes descrevem seus sintomas de forma evasiva, outros, com grande minúcia e detalhamento; são formas diferentes de expressar ansiedade diante do adoecer. Podem expressar sua angústia no corpo, como dor, espasmos, problemas digestivos... ou seja, somatizam (ver Cap. 17). Na internação, o paciente com ansiedade pode ter diminuição do limiar para a dor, levando à maior prescrição de analgésicos, principalmente após o anoitecer.

A ansiedade em um paciente internado pode representar uma reação psicológica à doença, à internação e ao ambiente hospitalar (reação de adaptação), mas pode também ser uma manifestação da doença propriamente dita (ansiedade secundária à condição médica geral) ou, ainda, um transtorno psiquiátrico preexistente (p. ex., transtorno de ansiedade generalizada).

Transtorno de adaptação (ansiedade de adaptação)

Quando os recursos psicológicos utilizados pelo paciente sofrem abalos e entram em falência, instala-se um estado de ansiedade intensa, com vulnerabilidade física e psíquica, comprometendo a boa evolução. Esse estado é identificado como transtorno de adaptação ou ajustamento, com sintomas ansiosos. O paciente se sente ansioso, oprimido e incapaz de pensar e pode apresentar sintomas físicos relacionados ao estresse, como cefaleia, dor abdominal, dor no peito e palpitações. Tais sintomas costumam ser associados a eventos estressantes (p. ex., antecedendo uma cirurgia, um exame invasivo), piora da doença, confirmação de um diagnóstico difícil (câncer, HIV/aids), complicações cirúrgicas (p. ex., deiscência, infecção) ou vivência prévia de um tratamento traumático.

A ansiedade intensa torna traumáticos a internação e os procedimentos, interfere na recuperação clínica, com aumento do tempo de internação ou, ao contrário, alta hospitalar a pedido do paciente, por não suportar a permanência no hospital. O manejo precoce dessa situação, com estratégias ambientais e farmacológicas, pode prevenir um mau desfecho.

O transtorno de adaptação é um quadro agudo que dura de alguns dias a várias semanas, remetendo com a melhora clínica, com a alta hospitalar ou com o desaparecimento da condição geradora da ansiedade. Caso a ansiedade persista por mais de um mês, após modificação da condição de estresse, deve-se considerar a hipótese de outro transtorno psiquiátrico associado.

Para pacientes debilitados, imunossuprimidos ou com quadro clínico instável, em que a ansiedade situacional é identificada como moderada a intensa, é recomendado o uso de ansiolíticos de ação rápida, além de medidas de apoio psicológico, pois o risco de piora clínica e morte é maior em função da ansiedade mantida. Os medicamentos utilizados para o controle da ansiedade e suas doses recomendadas para uso hospitalar encontram-se listados na Tabela 18.1.

Tabela 18.1

Medicamentos para o controle da ansiedade e doses recomendadas

Substância	Dose hospitalar	Meia-vida (h)	Metabólitos ativos
Diazepam	5-10 mg	30-100	Sim
Clonazepam	0,5-2 mg	18-50	Não
Lorazepam	1-4 mg	10-20	Não
Alprazolam	0,5-1 mg	6-20	Sim
Buspirona	15-30 mg	2-3	Sim
Fluoxetina	10-20 mg	48-96	Sim
Paroxetina	10-20 mg	20-30	Não
Sertralina	25-50 mg	20-30	Sim
Citalopram	10-20 mg	27-33	Não
Escitalopram	10-20 mg	27-33	Não
Propranolol	30-120 mg	2-3	Sim
Haloperidol	0,5-2,5 mg	10-19	Não
Risperidona	0,5-2 mg	3-5	Sim
Quetiapina	25-100 mg	5-7	Sim
Olanzapina	2,5-10 mg	24-36	Sim
Bromazepam	1,5-6 mg	8-18	Sim
Bupropiona	75-150 mg	8-39	Sim
Amitriptilina	10-50 mg	16-26	Sim
Imipramina	10-50 mg	5-30	Sim
Clomipramina	12,5-75 mg	13-36	Sim
Nortriptilina	10-25 mg	12-56	Sim
Trazodona	25-50 mg	5-9	Sim

Ansiedade secundária a condições médicas

Ansiedade pode ser sintoma de uma condição médica, que, devido a sua importância, exige na avaliação o diagnóstico diferencial com uma condição médica geral, intoxicação ou abstinência de substâncias, efeitos colaterais de medicações, interações medicamentosas ou a somatória de mais de um desses fatores. A avaliação dessas condições exige uma revisão cuidadosa dos

diagnósticos, com exames clínicos e laboratoriais, avaliação dos medicamentos em uso e interações farmacológicas e história de uso de substâncias psicoativas (e a caracterização de seu uso).

O Quadro 18.2 relaciona as principais condições clínicas que cursam com ansiedade.

QUADRO 18.2

Causas clínicas de ansiedade

Condições neurológicas

- Acatisia, discinesia
- Acidente vascular cerebral
- Dor neuropática
- Doença de Parkinson
- Encefalopatias
- Enxaquecas
- Epilepsia
- Esclerose múltipla
- Hemorragia subaracnóidea, intraparenquimatosa
- Hipertensão intracraniana
- *Miastenia gravis*
- Neurosífilis
- Neurites, polineurites
- Síndrome pós-concussiva
- Síndromes organocerebrais
- Tremor essencial
- Tumores intracranianos
- Síndrome vestibular

Relacionadas a substâncias/intoxicação

- Álcool
- Alucinógenos
- Analgésicos
- Anestésicos (lidocaína)
- Anfetamina
- Ansiolíticos (reação paradoxal)
- Anti-hipertensivos
- Anticolinérgicos
- Anticonvulsivantes
- Antidepressivos
- Anti-inflamatórios não esteroides
- Antiparkinsonianos
- Antituberculostáticos (isoniazida)
- Cafeína
- Cocaína
- Corticosteroides
- Digitálicos
- Glutamato monossódico (molho *shoyu*)
- Hormônios tireoidianos

- Maconha
- Neurolépticos (acatisia)
- Quimioterápicos
- Salicilatos
- Simpatomiméticos broncodilatadores
- Simpatomiméticos descongestionantes
- Tabaco

Abstinência

- Álcool
- Anfetamina
- Antidepressivos
- Betabloqueadores
- Cafeína
- Cocaína
- Crack
- Maconha
- Narcóticos
- Nicotina
- Opiáceos
- Sedativos hipnóticos

Condições imunológicas

- Anafilaxia
- Arterite temporal
- Artrite reumatoide
- Colites
- Doença de Crohn
- Doença de Renaux
- Espondilite anquilosante
- Lúpus eritematoso sistêmico
- Pênfigo foliáceo
- Poliarterite nodosa
- Psoríase
- Urticária
- Vitiligo

Condições cardiovasculares e circulatórias

- Anemias
- Aneurismas
- Arritmias
- Choque cardiovascular
- Doença coronariana (*angina pectoris*)
- Doenças valvulares (prolapso de valva mitral)
- Hipertensão arterial
- Hipotensão arterial
- Hipovolemia
- Infarto agudo do miocárdio
- Insuficiência cardíaca congestiva
- Insuficiência vascular cerebral (anoxia)

- Reação vasovagal
- Síncope, lipotimia

Condições infecciosas

- Brucelose
- Choque séptico
- Hepatite viral
- Herpes-zóster
- Malária
- Meningite
- Mononucleose
- Síndrome da imunodeficiência adquirida (HIV/aids)
- Tuberculose
- Varicela

Condições endócrinas e metabólicas

- Acidose metabólica
- Andropausa
- Carcinoma pancreático
- Cetoacidose
- Deficiência testicular
- Deficiências vitamínicas
- Doença de Wilson
- Doenças da hipófise
- Feocromocitoma
- Hipercalemia
- Hiperglicemia
- Hiperparatireoidismo
- Hipertermia
- Hipertireoidismo
- Hipocalcemia
- Hipocalemia
- Hipoglicemia
- Hiponatremia
- Hipotireoidismo
- Insulinoma
- Menopausa
- Porfirias
- Síndrome carcinoide
- Síndrome de Addison
- Síndrome de Cushing
- Síndrome do ovário policístico
- Tensão pré-menstrual
- Intoxicação por metais pesados

Condições respiratórias

- Asma
- Câncer pulmonar
- Dependência do respirador (síndrome do desmame)
- Doença pulmonar obstrutiva crônica

- Edema pulmonar
- Embolia pulmonar
- Hiperapnia
- Hiperventilação
- Hipoxia
- Pneumonia
- Pneumotórax

TRANSTORNOS DE ANSIEDADE

Os transtornos de ansiedade são patologias psiquiátricas com frequência encontradas na população em geral. No Brasil, sua prevalência é elevada, sendo o principal problema de saúde mental em grandes centros urbanos. A ansiedade pode ser um fator de risco para doenças (aumenta o risco para hipertensão arterial e doenças cardiovasculares)^{2,3} ou exacerbar sintomas somáticos, como angina, arritmias, distonias, diarreias.

O paciente com transtorno de ansiedade, quando internado, pode apresentar-se inicialmente com sintomas físicos relacionados à tensão (p. ex., dor de cabeça, palpitações) ou mentais (como insônia, questionamentos sobre medicações, controle ostensivo do tratamento). A investigação adicional revelará presença de ansiedade importante mantida ao longo do tempo.

Para o diagnóstico, deve-se interrogar sobre sintomas somáticos e mentais da ansiedade (Quadro 18.1), pois o paciente adaptado a alto grau de ansiedade pode não se aperceber dos sintomas ansiosos ou mesmo banalizá-los (“Eu sempre fui ansioso”). Um paciente com essas características pode requerer mais compreensão e paciência por parte da equipe de cuidados.

Alguns pacientes apresentam medo extremo de situações específicas (fobias). As fobias mais reconhecidas no ambiente hospitalar são de doenças, de exames (p. ex., tubo de ressonância magnética), de agulhas e de sangue. Os pacientes com fobias de doenças e tratamentos sofrem quando precisam de atendimento médico ou internação e tentam evitar essas situações (como recusa a submeter-se a procedimentos) ou adiá-las. (“Vamos programar a cirurgia para o início do ano”). A ansiedade que os pacientes fóbicos apresentam é potencializada na internação, tornando a experiência traumática. Eles necessitam de apoio psicológico e prescrição de ansiolíticos para suportarem o tratamento hospitalar.

Transtorno de estresse agudo e transtorno de estresse pós-traumático (TEPT)

Em hospitais, é frequente a admissão de pacientes com ansiedade aguda decorrente de situação traumática específica recém-ocorrida, com grande impacto e sofrimento psíquico. O estressor é uma experiência traumática com grave ameaça à segurança e à integridade física do paciente (p. ex., acidente, assalto, estupro, sequestro).⁴

A reação aguda ao estresse, ou transtorno de estresse agudo, caracteriza-se por um estado de ansiedade intensa, intenso medo ou horror, ataques de pânico, agitação, tremores, choro e desespero, mas pode se manifestar por desorientação, estreitamento da consciência e estados dissociativos. Os sintomas surgem nas primeiras horas após o acontecimento traumático e são consequência (reação) direta desse evento. A volta ao normal ocorre de alguns dias até semanas, mas o estado pode tornar-se crônico. A partir de um mês de duração dos sintomas, não nos referimos mais a estresse agudo, e sim a transtorno do estresse pós-traumático.

O transtorno de estresse agudo pode acompanhar condições médicas agudas de ameaça à vida (p. ex., infarto agudo do miocárdio, embolia pulmonar e abortamento), procedimentos agressivos (cateterismo) e internação em unidade de alto estresse (unidade de terapia intensiva, unidade de transplante de medula óssea).

O impacto da experiência traumática (e a reação aguda ao estresse) é uma vivência única e pessoal, influenciada por fatores de vulnerabilidade e pela capacidade de enfrentamento ao trauma, ou seja, dependerá dos recursos psíquicos desenvolvidos ao longo da vida. Por isso, antes de julgar a forma de resposta ao trauma, é preciso buscar compreender a pessoa traumatizada, em uma escuta empática, e ajudá-la a minimizar o sofrimento, com medidas de apoio psicológico e ansiolíticos, quando necessário.

Um acontecimento extremamente traumático em qualquer idade e circunstância é a violência sexual, tanto decorrente de assédio por desconhecido (violência urbana) quanto por pessoa da convivência íntima (violência doméstica ou abuso intrafamiliar). Por ser muito prevalente em nosso meio, traz, se não tratada, repercussões graves em curto, médio e longo prazos. É uma situação que requer atendimento emergencial especializado, o mais rápido possível, em função de avaliação clínica geral, coleta de material (exames médico-legais), profilaxias (doenças sexualmente transmissíveis, tétano e anticoncepção), cuidados dos danos físicos (lesões, rupturas, fraturas) e psicológicos (reação ao estresse agudo).

Busca-se, nos serviços públicos de assistência emergencial a vítimas de violência, humanização do atendimento, sem burocracias para a admissão, com acolhimento diferenciado, realização de boletim de ocorrência e notificação ao Conselho Tutelar (obrigatórios em caso de crianças e adolescentes), otimização dos recursos (orientações e medicações para a continuidade do tratamento em casa) e garantia da assistência médica e psicológica para esse momento.⁵⁻⁸

Essas medidas centralizadas no primeiro atendimento visam diminuir o trauma da revitimização, que é uma experiência estressante que a pessoa pós-violência sexual pode passar prestando informações e expondo-se a avaliações em diversos serviços, em um momento em que está muito fragilizada e traumatizada. Além disso, é preciso entender que a vítima de violência sexual recém-ocorrida não possa ou não queira falar sobre o episódio; por isso, é conveniente que apenas um profissional colha as informações e, se necessário, complemente os dados com o acompanhante ou outras fontes, para que proceda corretamente à avaliação e ao diagnóstico.

O profissional que acolhe a vítima de violência recém-ocorrida deve estar disposto a ajudar, promovendo ambiente reservado e limitando-se a fazer perguntas objetivas que permitam avaliar seu estado físico e emocional. É recomendado evitar perguntas desnecessárias e facilitar a manifestação de sentimentos eruptivos, respeitando o ritmo e o fluxo da entrevista. Ao fim, deve-se propor formas de alívio para minimizar as vivências traumáticas.

A boa assistência e o bom manejo dos sintomas no transtorno de estresse agudo são determinantes para a superação do trauma e a prevenção do transtorno de estresse pós-traumático. É necessário garantir o alívio rápido da ansiedade associada ao trauma. Benzodiazepínicos de meia-vida média (alprazolam, clonazepam) podem ser administrados já na admissão, e hipnoindutores, nos primeiros dias, pois insônia e pesadelos são frequentes. É comum surgirem dificuldades alimentares, náuseas e vômitos nas primeiras semanas após a violência sexual, dificultando ou impedindo o uso de medicação, mesmo ansiolítica.

A sensibilização para o tratamento psicoterápico começa no atendimento emergencial. A proposta se dá com explicações sobre as modalidades (psicoterapia em grupo, cognitivo-comportamental, logoterapia), uma vez que elas apresentam bons resultados, e essas informações

podem ajudar a identificar preferências. Um encaminhamento personalizado pode ajudar na adesão. Outras formas de ajuda, dentro da referência de valor e cultura pessoal, devem ser encorajadas.

A não superação do trauma leva, em médio e longo prazos, a depressão, fobias, somatizações, distúrbios do sono, abuso e dependência de álcool, substâncias psicoativas e ansiolíticos, dificuldades sexuais, distímia, transtorno obsessivo-compulsivo, transtornos da personalidade e outras comorbidades psiquiátricas (transtorno alimentar, tentativas de suicídio, exposição a acidentes e outras violências).

O TEPT é uma resposta retardada a uma situação excepcionalmente estressante. Os sintomas incluem crises de ansiedade ante uma situação que lembre o ocorrido, revivências do evento (*flashback*), pesadelos, insônia e outros distúrbios do sono.

Há evidências de que fatores predisponentes, como problemas no desenvolvimento da personalidade (traços de imaturidade na personalidade), exposição a trauma anterior ao ocorrido, bem como a não elaboração da experiência traumática (por não ter recebido assistência adequada no momento do trauma), podem diminuir o limiar para ocorrência da reação tardia ao trauma ou agravar sua evolução.^{9,10}

Por isso, a identificação precoce desses fatores pode levar à estratégia de cuidados prevenindo agravamento dos danos. O tratamento farmacológico dos sintomas ansiosos (crônicos) visa ao alívio e ao controle a longo prazo, dando-se preferência, nesse caso, ao uso de antidepressivos (ver Tab. 18.1), que são iniciados em doses baixas, com aumento gradativo para adequado ajuste. A psicoterapia pode promover mudanças significativas na autoaceitação e autoestima. No enfrentamento do trauma, a logoterapia (psicoterapia analítica centrada no sentido) tem-se mostrado eficiente para a aceitação e a superação, em uma perspectiva de busca de novos projetos de vida voltados para o sentido à vida.¹¹

Se não tratado, o TEPT leva, a longo prazo, a perdas sociais, diminuição da capacidade de trabalho, sentimentos de culpa e menos valia, depressão, irritabilidade, maior sensibilidade ao estresse, fobias específicas, uso de álcool, drogas e ansiolíticos, somatizações e morte prematura.

Transtorno de pânico

Em unidades de emergência, é comum pacientes buscarem o atendimento com dor no peito e sensação de morte iminente e, após avaliação clínica, receberem o diagnóstico de ataque de pânico.¹²

No transtorno de pânico, as crises desencadeiam-se subitamente, com palpitações, dor no peito, falta de ar, tontura, sentimento de despersonalização e desrealização, ansiedade intensa, sensações de perda de controle, medo de enlouquecer ou de morte iminente. Esses ataques são recorrentes e imprevisíveis. Um ataque de pânico leva ao medo de outro ataque e à evitação de lugares onde os ataques ocorreram (agorafobia).

Em hospitais, o psiquiatra pode ser chamado para atender o paciente em ataque de pânico durante exame (p. ex., ressonância magnética, tomografia) ou a criança que chega na antessala

cirúrgica e entra em crise de ansiedade, tipo pânico, em função de experiência traumática em cirurgia anterior.

Para fazer o diagnóstico, é importante considerar as condições clínicas que podem causar sintomas semelhantes a ataques de pânico, como arritmias, isquemia cerebral, doença coronariana, tireotoxicose e feocromocitoma.¹³ É comum a associação entre transtorno de pânico e outras doenças, como doença pulmonar obstrutiva crônica (DPOC), hipertensão arterial e síndrome do cólon irritável.¹⁴

Pacientes com transtorno de pânico podem ter sintomas exacerbados quando adoecem fisicamente, e isso pode dificultar o diagnóstico e as intervenções. Na internação, esses pacientes precisam de apoio psicológico e prescrição de ansiolíticos, para prevenção de vivências traumáticas.

Transtorno de ansiedade generalizada (TAG)

O paciente com ansiedade generalizada é caracterizado como uma pessoa preocupada e nervosa. Apresenta elevada ansiedade persistente ou flutuante, além de alterações do sono. Também é um transtorno de ansiedade que requer diagnóstico diferencial com as condições médicas que cursam com ansiedade (Quadro 18.2).

Na internação para exames ou tratamento hospitalar, os sintomas do TAG são agravados por eventos estressantes, como a própria doença, exames invasivos ou o ambiente hospitalar. É comum esse paciente, que apresenta tendência crônica à preocupação, fazer uso de ansiolíticos; portanto, é preciso interrogá-lo a esse respeito e, se confirmado, prescrevê-lo, devido ao risco de síndrome de abstinência. Pode ser necessário ajuste de dose em função do aumento da ansiedade. Quando não percebida como um desconforto, o paciente pode recusar o uso de ansiolíticos, mesmo com sinais evidentes de alta ansiedade, pois teme dependência ou sedação. A conquista da confiança e prescrições de ansiolíticos de meia-vida média (ver Tab. 18.1), em baixas doses e com aumentos gradativos, podem ser uma oportunidade para sensibilizar o paciente a respeito de sua ansiedade e convencê-lo a iniciar tratamento.

Transtorno obsessivo-compulsivo (TOC)

No hospital, o paciente com TOC sofre aumento importante da ansiedade, pelas mudanças trazidas na internação, e o ambiente hospitalar não promove condições para diminuição desta. Para aqueles que obtêm alívio com rituais compulsivos, a incapacidade física ou a própria rotina do hospital tornam impossível a realização destes. A ansiedade da internação leva à necessidade de maior controle do ambiente, como aferição do gotejamento do soro e dos horários das medicações, trazendo solicitações frequentes à equipe e provocando ansiedade.

A prescrição de ansiolíticos (Tab. 18.1) ou o ajuste de dose da medicação em uso costumam aliviar os sintomas, tornando suportável a internação.

AVALIAÇÃO E DIAGNÓSTICO

O estado clínico e emocional do paciente deve ser priorizado antes de se considerar a possibilidade de uma entrevista exaustiva. É recomendável realizar uma breve entrevista inicial, obtendo-se as informações complementares posteriormente com o próprio paciente, o acompanhante, os familiares, a equipe médica e o prontuário médico.

Na coleta de dados, busca-se:

- identificar o padrão de ansiedade presente
- encontrar elementos desencadeantes da ansiedade
- considerar sintomas, sinais, curso e intensidade
- pesquisar condições clínicas geradoras de ansiedade como sintoma (Quadro 18.2)
- avaliar ocorrências na evolução clínica, como piora ou descompensação
- interrogar sobre o uso de substâncias que causam ansiedade (Quadro 18.2)
- investigar transtornos de ansiedade (TAG, pânico, TEPT)
- observar condições adversas do ambiente hospitalar (transferência para UTI, morte de paciente em sua unidade)

O exame físico deve valorizar o estado geral e a ocorrência de febre, desidratação, anemia, hipertensão arterial, arritmias e insuficiência respiratória. A avaliação laboratorial mínima deve incluir hemograma completo, eletrólitos, glicemia, ureia e creatinina, função tireoidiana e eletrocardiograma. Outros exames complementares podem ser sugeridos, com a manutenção dos sintomas, como radiografia de tórax, função hepática, ressonância magnética (RM) ou tomografia de sistema nervoso central, *screening* para drogas, etc. Para a confirmação do diagnóstico, é necessário observar a medicação em uso e realizar o exame do estado mental.

Escala de avaliação de ansiedade são empregadas para diagnóstico e avaliação da gravidade e facilitar estudos comparativos. No Brasil, várias são as escalas traduzidas e validadas para identificar transtornos mentais e emocionais em pacientes em tratamento hospitalar.^{15,16} A Escala Hospitalar de Ansiedade e Depressão (HAD), por exemplo, com sete itens para identificar ansiedade e sete para depressão, tem a vantagem de ser de fácil e rápida aplicação, não exigindo um grande esforço do paciente (ver anexo do Cap. 9).

MANEJO E TRATAMENTO

Apoio psicológico prestado pelo médico

O objetivo do apoio psicológico ao paciente é o alívio do sofrimento mediante compreensão, elaboração da ansiedade (fortalecimento do ego) e aceitação de sua realidade. Assim, o paciente amplia sua consciência e adquire mais recursos para suportar procedimentos e fazer escolhas quanto ao tratamento.

A intervenção psicológica se dará, muitas vezes, em situações pouco favoráveis (como em enfermaria coletiva, UTI, unidade de hemodiálise, sala pré-cirúrgica), exigindo que o médico improvise para que haja condições para garantir alguma privacidade. A atitude do médico deve ser de respeito ao sofrimento do paciente. Apoio é, antes de tudo, ouvir o paciente com disponibilidade real, empática.

Ainda que ouvir um paciente ansioso desperte, no médico, o desejo de aconselhar e orientar, não é bom nem necessário que isso aconteça em um primeiro encontro. Como os quadros de ansiedade costumam ser acompanhados de sintomas somáticos, que trazem grande desconforto, o médico pode, em uma primeira conversa, reassegurar, ao paciente, que ele terá todo o seu empenho para o alívio do desconforto.

É fundamental evitar asseguramentos como “isso não é nada” ou “não há com o que se preocupar”, pois, além de serem infundados, não dão alívio duradouro. Diagnósticos como “você está muito tenso” ou “isso é apenas ansiedade” não ajudam o paciente a lidar com seus sintomas, pois provocam sentimento de revolta e podem aumentar a ansiedade. O Capítulo 26, “Crise: abordagem psicodinâmica”, aprofunda-se nesse tema.

Abordagens psicoterapêuticas

Psicoterapia focal

Algumas vezes, é necessária uma compreensão mais profunda das dificuldades psicológicas do paciente. Nesse caso, um profissional de saúde mental pode ser chamado para intervir. Busca-se, com a psicoterapia focal, fortalecer as defesas do ego do paciente. A psicoterapia focal é um recurso útil, mesmo na internação curta ou em condições de preparo cirúrgico. A psicoterapia cognitivo-comportamental é muito apropriada para o manejo da ansiedade em pacientes hospitalares.

Terapia ocupacional

A terapia ocupacional (TO) tem sido proposta para auxiliar os pacientes internados a enfrentar melhor as angústias ante situações de doença, internação e adaptação para perdas e luto. A TO utiliza outros recursos além da conversa (como atividades, jogos, reorganização funcional), com o objetivo de facilitar a elaboração da situação de crise e diminuir a ansiedade. O atendimento

individual ou em grupo para pacientes com limitações específicas (doentes oncológicos, hemodialisados, obesos mórbidos, doentes neurológicos ou com perdas funcionais) auxilia nos processos de readaptação e cooperação para o tratamento médico.¹⁷

Estratégias complementares

Assistência espiritual

A presença do religioso a pedido do paciente ou familiar, principalmente em momentos críticos e na proximidade da morte, tranquiliza, reduzindo muito a ansiedade, associada sobretudo a aspectos morais e medos. Apoio espiritual ao doente internado, prestado de modo ético, não religioso, tem sido oferecido aos doentes internados, com observada diminuição do estresse e melhor adaptação ao ambiente hospitalar. A finalidade é levar conforto espiritual ao paciente e ao acompanhante, uma palavra de esperança ou mesmo uma oração, se assim desejarem.^{18, 19}

Reiki, relaxamento e meditação

Técnicas complementares têm sido empregadas em hospitais e unidades de emergência e são muito eficazes para pacientes que apresentam ansiedade. São estratégias de abordagem não religiosa, bem aceitas pelos doentes, com o objetivo de potencializar o tratamento médico, contribuindo para a diminuição dos sintomas de ansiedade, melhora do sono e redução de dor, favorecendo o controle emocional.²⁰⁻²² Sobre relaxamento e meditação, técnica e uso desses recursos durante a internação hospitalar, recomenda-se a leitura do apêndice do Capítulo 26.

Medidas ambientais

O hospital é um ambiente ansiogênico. Apesar de planejado para ser um local de recuperação e repouso, guarda a doença, a dor e o sofrimento, além de representar a ideia de última morada. No hospital, estão reunidos as nossas esperanças de cura e os nossos medos e temores.

Imediatamente após a internação, uma ambientação em até 24 horas promove a redução da ansiedade inicial. Pacientes que apresentam ansiedade persistente após esse período podem se tranquilizar com a presença de um acompanhante em um período do dia ou à noite. É importante estar alerta ao relacionamento do paciente com seu acompanhante (familiar ou não), pois este pode aumentar a ansiedade, em vez de reduzi-la.

Em unidades de isolamento, a cor das paredes e a presença de luz e ventilação naturais podem diminuir a tensão. Outros recursos ambientais muito eficazes são música tranquila e personalização do ambiente (p. ex., porta-retratos). Espaços abertos para caminhar, capela e jardim são recursos ambientais que reduzem a ansiedade e facilitam a permanência do doente no hospital. Em UTIs, os aparelhos de controles vitais sonoros causam ansiedade de nível elevado e insônia importante, assim como a convivência com pacientes terminais, doentes com dor refratária, sangramentos ou incisões abertas. Muitas vezes, a transferência de leito reduz a ansiedade.

Crianças internadas em hospitais precisam de condições apropriadas para que seu tratamento seja o menos traumático possível. Para isso, projetos de humanização do ambiente hospitalar incluem, além de acomodações para as crianças com suas mães, salas de recreação, de escola e brinquedos ao ar livre. As unidades pediátricas para tratamento especializado têm utilizado o recurso lúdico para diminuir o estresse em crianças gravemente doentes. Recreacionistas e voluntários podem ser chamados para brincar e se propõem a levar o riso para dentro do hospital, reduzindo a tensão e o sofrimento da internação.²³

Medidas psicofarmacológicas

Os psicofármacos mais utilizados para a tranquilização são os benzodiazepínicos (BDZs). Eles são empregados nas ansiedades situacionais e nos transtornos de ansiedade por proporcionarem alívio rápido e constante de forma eficaz, além de serem bem tolerados. Porém, podem causar sedação, sonolência diurna, prejuízo no desempenho cognitivo, retardo ou descoordenação psicomotora, sobretudo quando associados a opioides.

Dá-se preferência por iniciar em dose baixa, com aumento progressivo, por via oral, e em horários compatíveis. Recomenda-se, na alta hospitalar, a descontinuação gradativa, devido ao risco relacionado a quedas, com consequentes fraturas (idosos), dependência ou síndrome de abstinência.

Outras medicações que podem ser utilizadas para tratamento da ansiedade são antidepressivos tricíclicos, inibidores seletivos da recaptação de serotonina (ISRSs), antipsicóticos em baixa dose e betabloqueadores.

Os antidepressivos (como amitriptilina e citalopram) apresentam algumas vantagens sobre os benzodiazepínicos, como menor risco de abuso ou dependência e eficácia em vários transtornos de ansiedade e na depressão, bem como no manejo da dor de difícil controle. No entanto, têm como desvantagens os efeitos colaterais (como sonolência ou agitação, hipotensão, ganho de peso, disfunção sexual, cefaleia, náusea, constipação), aumento da ansiedade nos primeiros dias (efeito produzido por ISRSs), início de ação demorado (2 a 4 semanas), interações medicamentosas e agravamento da condição médica (como no uso de tricíclicos em pacientes com glaucoma de ângulo estreito e cardiopatia com bloqueio de ramo).

Para a escolha dos ansiolíticos, deve-se levar em consideração as patologias presentes, o tempo para o início de ação, o estado nutricional e a via de metabolização (função hepática) e de excreção (função renal).

A Tabela 18.1 apresenta medicamentos e doses para manejo da ansiedade no contexto hospitalar.

SITUAÇÕES ESPECIAIS

Para maior detalhamento deste tópico, recomenda-se a leitura do Capítulo 24, que se ocupa do uso de psicofármacos em situações clínicas especiais. Aqui fazemos apenas observações concisas.

Idosos

A decisão de medicar um paciente idoso com ansiedade deve considerar os seguintes cuidados: a resposta a tratamentos anteriores, a natureza dos sintomas, o uso de medicamentos concomitantes e o perfil de efeitos colaterais aceitáveis. Os efeitos adversos indesejáveis mais comuns devido ao uso de psicofármacos são hipotensão ortostática, arritmias e retenção urinária. Para preveni-los, recomenda-se iniciar com um terço da dose habitualmente indicada para adultos, aumentando de modo lento até resposta terapêutica.

Quando um benzodiazepínico for o medicamento de escolha para o tratamento de um paciente idoso, deve-se dar preferência a um que tenha meia-vida curta e não apresente metabólitos ativos. Além disso, a prescrição deve ser por um período limitado, de, no máximo, quatro semanas (o lorazepam tem essas qualidades, é metabolizado por conjugação e não apresenta acúmulo relacionado a metabólitos).²⁴ No entanto, quando há necessidade de manutenção da medicação ansiolítica por mais de um mês, recomenda-se o uso de antipsicóticos e antidepressivos (ISRSs) em baixa dose, com o cuidado de ajuste desta.

Gravidez e puerpério

O risco potencial de um psicofármaco sobre o feto ou o lactente deve ser ponderado em relação ao risco da ansiedade da mãe. Os benzodiazepínicos apresentam risco para malformações congênitas, sobretudo no primeiro trimestre da gravidez. Necessitam de maior cautela quando usados no fim da gestação, pois podem causar a síndrome do bebê hipotônico.

A exposição à paroxetina e à fluoxetina no início da gestação pode aumentar o risco de malformações cardíacas, porém esse risco é baixo. Já outros ISRSs não têm apresentado risco aumentado de malformações.

As informações disponíveis até o momento mostram que, embora presentes no leite materno, as concentrações dos psicofármacos são baixas e, na maior parte dos casos, não produzem efeitos indesejáveis ao lactente. O lítio é uma das poucas exceções.²⁵

Cardiopatias e doença pulmonar obstrutiva crônica

Nos pacientes com infarto agudo do miocárdico, o controle da ansiedade pode diminuir a produção ou o efeito das catecolaminas circulantes, reduzindo a possibilidade de taquiarritmias.

A hipoxemia pode ser uma das causas de ansiedade em pacientes com doença pulmonar. Os benzodiazepínicos costumam ser úteis nessas situações, devendo-se, no entanto, tomar o cuidado de iniciar a administração em doses baixas (um terço de dose), monitorando o risco de depressão respiratória. Caso isso ocorra ou haja intoxicação por benzodiazepínicos, o emprego do antagonista específico, flumazenil, pode melhorar a condição do paciente.

Disfunções hepáticas e renais

Nos casos de comprometimento renal ou hepático em que haja necessidade de uso de benzodiazepínicos, deve-se dar preferência ao lorazepam, por não apresentar metabólitos ativos e sua metabolização ocorrer por conjugação simples. Em pacientes com insuficiência renal, deve-se usar metade a dois terços da dose recomendada para pacientes com função renal normal e evitar o uso de benzodiazepínicos de meia-vida longa, pois a hemodiálise retarda a eliminação desses medicamentos.

Queimados

O diazepam pode ter aumento da meia-vida e da fração de droga livre no plasma em decorrência da diminuição dos níveis de albumina e da capacidade metabolizadora do fígado nessas condições. O lorazepam tem seu *clearance* aumentado em pacientes queimados, sendo esse ansiolítico a melhor escolha.²⁶

INSÔNIA

Fisiologia do sono

O sono normal é composto de uma sequência de eventos e condições fisiológicas, denominada arquitetura do sono, em que dois estados distintos se intercalam: o sono sem movimentos rápidos dos olhos, ou sono NREM (derivado do inglês *non-rapid eye movement*), e o sono com movimentos rápidos dos olhos, ou sono REM (*rapid eye movement*), quando ocorrem os sonhos. No sono NREM, são reconhecidos quatro estágios, com base nos registros das ondas cerebrais geradas durante o sono (polissonografia).

Os estágios 1 e 2 são considerados de sono leve e ocupam a maior parte da noite. Os estágios 3 e 4 estão relacionados ao sono profundo, reparador e de descanso. Nestes últimos, são produzidas ondas cerebrais lentas e de grande amplitude, chamadas ondas delta; juntos, tais estágios também são denominados “sono delta”.

Os estágios do sono ocorrem de maneira cíclica durante a noite, e seu ritmo pode ser alterado por vários fatores, como idade, história prévia de sono, ritmos circadianos, temperatura do ambiente, ingestão de alimentos, medicamentos e patologias diversas.

Ao longo do desenvolvimento, o padrão de sono vai se modificando progressivamente. Durante a infância, existe necessidade maior de sono, de 16 a 20 horas por dia. Na vida adulta, a necessidade de sono varia de 7 a 8 horas, e, após os 60 anos, cai para aproximadamente 6 horas e meia. O sono delta, mais profundo e reparador, diminui com a idade, passando a predominar o estágio 1, que tem limiar menor para o despertar. Isso pode ajudar a compreender por que, com a idade, ocorrem breves períodos de despertar durante a noite.

A necessidade de sono é individual. Algumas pessoas se sentem bem com menos de 5 horas de sono, outras, necessitam de mais de 10 horas. A quantidade de sono ideal para uma pessoa é definida pelo período de sono que permite um bom desempenho de suas atividades diurnas, sem a sensação de sonolência ou o prejuízo da concentração.

Transtornos do sono

Os transtornos do sono são classificados da seguinte forma: transtorno de insônia, transtornos do sono relacionados à respiração, transtorno de hipersonolência, transtornos do ritmo circadiano, parassonias e transtornos do movimento relacionados ao sono.²⁷

Insônia

A insônia é a mais comum das disfunções do sono e se caracteriza por uma queixa de dificuldade para iniciar ou manter o sono ou pela sensação de não ter um sono reparador. Estima-se que cerca de um terço da população adulta nos países ocidentais apresente algum problema relacionado ao sono pelo menos uma vez por semana.²⁸

A insônia pode ter muitas origens e é diagnosticada após uma avaliação médica apropriada. Os transtornos associados à insônia incluem distúrbio de ajustamento do sono, insônia psicofisiológica, higiene do sono inadequada, condições psiquiátricas, condições médicas e neurológicas, drogas e transtornos intrínsecos do sono. O Quadro 18.3 resume as principais condições que cursam com insônia.

QUADRO 18.3

Principais condições que cursam com alterações do sono

Condições associadas	Transtornos intrínsecos do sono
■ Distúrbio de ajustamento do sono ■ Insônia psicofisiológica ■ Higiene do sono inadequada ■ Condições psiquiátricas ■ Condições médicas gerais ■ Condições neurológicas ■ Uso de substâncias	■ Apneia do sono ■ Narcolepsia ■ Alterações do ritmo circadiano ■ Parassonias ■ Distúrbios do movimento relacionados ao sono

A insônia pode adquirir características crônicas, autônomas e persistentes. Após várias noites de insônia, o quarto se torna associado à impossibilidade de dormir, e a ansiedade cresce à medida que se aproxima a hora de deitar. O paciente desenvolve, então, ansiedade antecipatória à possibilidade de outra noite acordado, à qual se seguirá outro dia de cansaço. O tratamento da insônia crônica combina estratégias comportamentais, como o cuidado com a higiene do sono, e uso de farmacoterapia.²⁹ O Quadro 18.4 mostra os cuidados para uma boa higiene do sono.

QUADRO 18.4

Recomendações para a boa higiene do sono

- Manter um horário regular para acordar e dormir.
- Evitar permanecer muito tempo na cama.
- Evitar o uso de nicotina, cafeína ou álcool.
- Usar a cama somente para dormir e manter relações sexuais.
- Não usar a cama para ler, assistir à televisão ou alimentar-se.
- Fazer algo relaxante antes de dormir.
- Não ficar olhando o relógio.
- Evitar cochilos durante o dia.
- Fazer exercícios regularmente durante o dia.
- Ter um horário regular para se alimentar.
- Fazer um lanche leve antes de dormir, se tiver fome.
- Expor-se regularmente à luz do sol, principalmente à tarde.
- Evitar pensar em problemas na hora de dormir.
- Fazer uma lista dos problemas a resolver no dia seguinte.
- Só ir para a cama com sono.
- Se não conseguir dormir em 15 a 20 minutos, ir para outro cômodo.
- Só voltar para a cama com sono.

Síndrome da apneia obstrutiva do sono (SAOS)

A síndrome da apneia obstrutiva do sono (SAOS) se caracteriza pela lentificação ou pela interrupção da respiração durante o sono, causada por estreitamento ou obstrução parcial das vias aéreas superiores, provocando interrupção do fluxo de ar por cerca de 10 segundos e decréscimo na saturação de hemoglobina. A resposta fisiológica é o despertar, que interrompe o período de apneia. Outros sintomas incluem roncos altos, sensação de sufocação durante o sono, boca seca e cefaleia pela manhã e disfunção sexual. Ocorre com mais frequência em indivíduos obesos e com hipotireoidismo.

O uso de sedativos hipnóticos deve ser evitado pelo risco de agravar a depressão respiratória. O tratamento varia desde terapias comportamentais, intervenções mecânicas (odontológicas e/ou cirúrgicas), que visam melhorar o fluxo do ar, até o uso de máscaras de pressão positiva de ar (CPAP – *continuous positive airway pressure*).

Uma grande variedade de drogas pode afetar o ciclo sono-vigília. Entre elas, estão betabloqueadores, hormônios tireoidianos, corticosteroides, ISRSs, IMAOs, teofilina, lamotrigina, metildopa, fenitoína e alguns agentes quimioterápicos. O álcool e os estimulantes, como nicotina e cafeína, também podem prejudicar o sono. Condições médicas, como refluxo gastroesofágico, doença pulmonar obstrutiva crônica, úlcera péptica, doença de Parkinson e outras doenças neurodegenerativas, asma, alergias do trato respiratório superior, hipertrofia prostática associada a incontinência urinária e insuficiência cardíaca congestiva associada a dispneia paroxística noturna, frequentemente atrapalham o sono. Mulheres no climatério podem ter uma alteração do sono relacionada à ocorrência de fogachos, que, nesses casos, pode ser uma indicação de terapia de reposição hormonal.

Transtornos psiquiátricos, como a depressão, podem ser causa de insônia crônica, sobretudo em idosos. Pesquisas epidemiológicas têm apontado a insônia como fator de risco para o desenvolvimento ou a recorrência de transtornos do humor, fator agravante para o risco suicida e sinal precoce de depressão (em especial em idosos) ou de um episódio maníaco em pacientes com transtorno bipolar.³⁰ Outras doenças psiquiátricas que podem cursar com insônia são os transtornos de ansiedade, a reação aguda ao estresse, o transtorno de estresse pós-traumático e as psicoses agudas.

Restrição de sono pode causar dor, principalmente cefaleia, assim como diminuir a tolerância à dor. As mais frequentes alterações do sono associadas à dor são a insônia inicial, o despertar frequente, a diminuição da duração do sono e a sensação de cansaço durante o dia.

Hipersonia

Os transtornos de hipersonia de origem central são caracterizados por sonolência diurna excessiva que não está relacionada a outro transtorno do sono, particularmente os que resultam em sono perturbado, como nos transtornos respiratórios do sono e/ou nas alterações do ritmo circadiano. Suas causas estão relacionadas a alterações intrínsecas do sistema nervoso central (SNC) no controle do ciclo sono-vigília (narcolepsia). Outras condições médicas que causam hipersonia, uso de substâncias e sono insuficiente induzido pelo comportamento também são classificados nesse subgrupo de transtornos do sono.

Narcolepsia

A narcolepsia é caracterizada por excessiva sonolência diurna, cataplexia (diminuição abrupta da força muscular desencadeada por reações emocionais, como riso, raiva ou medo), alucinações hipnagógicas (ocorrem na indução do sono), paralisia do sono (incapacidade para falar ou mover-se adormecendo ou acordando) e sono noturno perturbado. O tratamento requer avaliação especializada e inclui o uso de estimulantes do SNC (modafinil), anticolinérgicos e antidepressivos. É recomendado, ao paciente, programar cochilos durante o dia, o que alivia os sintomas.³¹

Parassonias

São alterações de movimento provocadas ou associadas ao sono. Sonambulismo e transtornos relacionados surgem de uma dissociação incompleta entre o despertar e o sono não REM. O distúrbio alimentar relacionado ao sono caracteriza-se por episódios de comer e/ou beber sempre involuntários durante despertares do sono que, em geral, ocorrem durante despertares parciais com consequente ausência de lembrança para o evento. Esses transtornos estão frequentemente associados ao uso de medicações sedativo-hipnóticas.

Distúrbios do comportamento do sono REM

Nos distúrbios do comportamento do sono REM, ocorre ausência de relaxamento muscular máximo, típico do sono REM; então, o indivíduo passa a executar movimentos associados ao sonho vivenciado. O espectro de comportamentos ou movimentos pode variar desde pequenos movimentos das mãos até movimentos violentos, como socar, chutar ou pular da cama.

Os transtornos do movimento do sono são caracterizados por movimentos simples, muitas vezes estereotipados, que ocorrem durante o sono. A síndrome das pernas inquietas caracteriza-se pela necessidade intensa e quase irresistível de movimentar as pernas. Essas sensações pioram durante o período de repouso e ocorrem com maior frequência no fim do dia e durante a noite. O movimento das pernas ou a deambulação costuma aliviar o desconforto percebido. O movimento periódico dos membros pode estar associado à síndrome das pernas inquietas, mas também pode ocorrer como distúrbio independente. Nesse caso, há movimentos repetitivos dos membros, de forma estereotipada, durante o sono. Bruxismo noturno consiste em episódios de ranger repetitivo dos dentes durante o sono, que podem gerar despertares. O bruxismo pode causar dor na articulação temporomandibular e desgaste dos dentes.

AVALIAÇÃO

A avaliação do paciente com insônia envolve investigação detalhada. É importante determinar se o paciente tem dificuldade para iniciar o sono, mantê-lo ou ambos. Também é útil estimar o número de vezes que o paciente desperta, se o sono está sendo reparador e que tipo de consequências a insônia vem trazendo. A duração, a frequência e o início do problema precisam ser avaliados. O surgimento gradual da insônia sugere uma etiologia comportamental. É necessário pesquisar ritmo circadiano e problemas psicológicos, médicos e psiquiátricos que possam estar presentes no início dos sintomas.

MANEJO E TRATAMENTO

O manejo da insônia depende de avaliação e diagnóstico adequados. Quando uma causa comportamental, médica ou psiquiátrica é identificada, deve ser tratada, mas, na maioria das situações, existem múltiplas causas determinando a insônia. Praticamente todo paciente com queixa de insônia beneficia-se de um planejamento terapêutico com orientações para melhorar a higiene do sono e uso de técnicas comportamentais, como restrição do sono, controle do estímulo, intervenção paradoxal e relaxamento.

As insônias transitórias relacionadas ao estresse, à internação hospitalar e às mudanças no horário ou no ambiente de dormir duram alguns dias e podem ser adequadamente manejadas com hipnóticos. Zaleplon e zolpidem são hipnóticos de meia-vida curta que têm sido recomendados por não prejudicarem o desempenho no dia seguinte. O uso de hipnóticos de meia-vida longa está associado a maior risco de descoordenação motora, quedas, acidentes automobilísticos e prejuízo da memória.

A insônia aguda dura algumas semanas e está associada a fatores estressantes ou doenças. O tratamento pode incluir orientações sobre higiene do sono e uso de hipnóticos por curto período.

Quando o paciente com insônia crônica necessita de internação hospitalar, é prudente iniciar medidas para controle adequado do sono desde os primeiros dias no hospital. É recomendado minimizar os aspectos ambientais perturbadores do sono, avaliar as comorbidades que aumentam a ansiedade e adequar o uso de medicações indutoras de sono e a interação com outras medicações prescritas.

Em pacientes com demência, o uso de trazodona (50 mg), um antidepressivo com ação sedativa, deve ser preferido, uma vez que os benzodiazepínicos aumentam o risco de agitação, confusão mental, amnésia, quedas e sonolência diurna. Outra possibilidade é o uso de agonistas dos receptores benzodiazepínicos (zaleplon e zolpidem), pois apresentam meia-vida menor, melhor tolerabilidade e menor risco de dependência.³²

REFERÊNCIAS

1. Rosenbaum J, Pollack M. Anxiety. In: Cassem NH, editor. Massachusetts general hospital handbook of general hospital psychiatry. St. Louis: Mosby Year Book; 1991.
2. Kibler JL, Joshi K, Ma M. Hypertension in relation to posttraumatic stress disorder and depression in the US National Comorbidity Survey. *Behav Med*. 2009;34(4):125-32.
3. Smoller JW, Pollack MH, Wassertheil-Smoller S, Jackson RD, Oberman A, Wong ND, et al. Panic attacks and risk of incident cardiovascular events among postmenopausal women in the Women's Health Initiative Observational Study. *Arch Gen Psychiatry*. 2007;64(10):1153-60.
4. Ursano RJ, Goldenberg M, Zhang L, Carlton J, Fullerton CS, Li H, et al. Posttraumatic stress disorder and traumatic stress: from bench to bedside, from war to disaster. *Ann N Y Acad Sci*. 2010;1208:72-81.
5. Ministério da Saúde (BR). Protocolos de atenção básica: saúde das mulheres. Brasília: MS; 2016.
6. Ministério da Saúde (BR). Portaria nº 1662, de 2 de outubro de 2015 [Internet]. Brasília: Poder e Saúde; 2015 [capturado em 04 fev. 2017]. Disponível em: http://www.poderesaude.com.br/novosite/images/publicacoes_06.10.2015-II.pdf.
7. Ministério da Saúde (BR). Prevenção e tratamento dos agravos resultantes da violência sexual contra mulheres e adolescentes. 3. ed. Brasília: MS; 2012.
8. Cabrera CC, Caccia Bava MCG, Monteiro E, Domingos NAM, Franceschini TRC. Protocolo para orientações, encaminhamentos e condutas em situações de violência intrafamiliar. In: Santos JS, Bliacheriene AC, Forster AC, Pereira Jr. GA. Protocolos clínicos e de regulação: acesso à rede de saúde. Rio de Janeiro: Elsevier; 2012. p. 161-85.
9. Camargo Filho JWS, Sougery EB. Transtorno de estresse pós traumático: formulação diagnóstica e questões de comorbidade. *Rev Bras Psiquiatr*. 2001;23(4):221-8.
10. Borges JL, Dell Aglio DD. Relações entre abuso sexual na infância, transtorno de estresse pós traumático e prejuízos cognitivos. *Psicol Estud*. 2008;13(2):371-9.
11. Frankl VE. Em busca de sentido: um psicólogo no campo de concentração. Petrópolis: Vozes; 1991.
12. Huffman JC, Pollack MH. Predicting panic disorder among patients with chest pain: an analysis of the literature. *Psychosomatics*. 2003;44(3):222-36.
13. Eisenhofer G, Sharabi Y, Pacak K. Unexplained symptomatic paroxysmal hypertension in pseudopheochromocytoma: a stress response disorder? *Ann N Y Acad Sci*. 2008;1148:469-78.
14. Sugaya N, Nomura S. Relationship between cognitive appraisals of symptoms and negative mood for subtypes of irritable bowel syndrome. *Biopsychosoc Med*. 2008;2:9.
15. Botega NJ, Bio MR, Zomignani MA, Garcia C, Pereira WA. Mood disorders among inpatients in ambulatory and validation of the anxiety and depression scale HAD. *Rev Saúde Pública*. 1995;29(5):355-63.

- Cabrera CC. Comparação dos resultados obtidos pela aplicação de um teste psicométrico em portadores de úlcera duodenal com resultados obtidos em uma população de referência [dissertação]. Ribeirão Preto: Universidade de São Paulo; 1991.
16. Morais LV. A interconsulta de terapia ocupacional no hospital geral: um espaço para a saúde. *Rev CETO*. 2001;6(6):9-13.
17. Guimaraes HP, Avezum A. O impacto da espiritualidade na saúde física. *Rev Psiq Clin*. 2007;34(Supl 1):88-94.
18. Redeapoioespiritualrp.blogspot.com.br [Internet]. Ribeira Preto: 2017 [capturado em 04 fev. 2017]. Disponível em: <http://redeapoioespiritualrp.blogspot.com.br/>.
19. Birotto N, Guilhame C, Storto S, Ritorto G, Catino C, Gir N, et al. The effects of Reiki therapy on pain and anxiety in patients attending a day oncology and infusion services unit. *Am J Hosp Palliat Care*. 2012;29(4):290-4.
20. Speca M, Carlson LE, Goodey E, Angen M. A randomized, wait-list controlled clinical trial: the effect of a mindfulness meditation-based stress reduction program on mood and symptoms of stress in cancer outpatients. *Psychosom Med*. 2000;62(5):613-22.
21. Creswell JD, Myers HF, Cole SW, Irwin MR. Mindfulness meditation training effects on CD4+ T lymphocytes in HIV-1 infected adults. *Brain Behav Immun*. 2009;23(2):184-8.
22. Cabrera CC. Projeto brincar. *Rev Serv Social-Hosp Clín*. 2001;1(1).
23. Sheikh JI, Cassidy EL. Treatment of anxiety disorders in the elderly: issues and strategies. *J Anxiety Disord*. 2000;14(2):173-90.
24. Kendall-Tackett K, Hale TW. The use of antidepressants in pregnant and breastfeeding women: a review of recent studies. *J Hum Lact*. 2010;26(2):187-95.
25. Jaehde U, Sörgel F. Clinical pharmacokinetics in patients with burns. *Clin Pharmacokinet*. 1995;29(1):15-28.
26. Sateia MJ. International classification of sleep disorders-third edition: highlights and modifications. *Chest*. 2014;146(5):1387-94.
27. LeBlanc M, Mérette C, Savard J, Ivers H, Baillargeon L, Morin C. Incidence and risk factors of insomnia in a population-based sample. *Sleep*. 2009;32(8):1027-37.
28. Doghramji K. The evaluation and management of insomnia. *Clin Chest Med*. 2010;31(2):327-39.
29. Benca RM, Peterson MJ. Insomnia and depression. *Sleep Med*. 2008;9(Suppl 1):S3-9.
30. Panossian LA, Avidan AY. Review of sleep disorders. *Med Clin North Am*. 2009;93(2):407-25.
31. Ooms S, Ju YE. Treatment of sleep disorders in dementia. *Curr Treat Options Neurol*. 2016;18(9):40.



Dependência de substâncias psicoativas: conceitos e abordagem

Renata Cruz Soares de Azevedo
Karina Diniz Oliveira

O consumo de substâncias psicoativas (SPAs) acompanha o ser humano há milênios. Atualmente, ele é causa potencial de dano psicossocial e à saúde. O momento da internação em um hospital geral pode ser precioso para desenvolver a motivação para o tratamento. A multicausalidade do fenômeno indica que a abordagem destinada às pessoas que apresentam um consumo problemático de SPAs deve ser também plural, incluindo um leque de alternativas terapêuticas (farmacológicas, motivacionais, familiares, psicoterápicas, mútua ajuda, entre outras) adequadas a sua condição particular. A maioria dos pacientes requer cuidados em longo prazo e apresenta episódios de lapsos e recaídas que fazem parte do tratamento e que não devem ser vistos como fracasso terapêutico.

As substâncias psicoativas têm o potencial de mudar processos de consciência, humor e pensamento individuais (Quadro 19.1).¹ O consumo de SPAs acompanha o ser humano há milênios, sendo associado tanto à busca por sensações prazerosas quanto a atos ritualísticos.² Atualmente, o consumo de SPAs deve ser considerado causa potencial de dano psicossocial e à saúde, não apenas entre os dependentes, mas também nos indivíduos com episódios eventuais de uso, particularmente em *binge*.¹

QUADRO 19.1

Classificação das substâncias psicoativas de acordo com sua principal ação no sistema nervoso central

Depressores	Estimulantes	Perturbadores
Álcool Benzodiazepínicos Solventes Opioides	Nicotina Anfetaminas Cocaína/ <i>crack</i> Metanfetaminas*	Maconha e canabinoides LSD Mescalina Anticolinérgicos

* Droga mista com ações estimulantes e perturbadoras.

Dessa maneira, o profissional da saúde deve estar sempre atento para a detecção do problema e disponível para oferecer tratamento para o dependente, mesmo que não seja essa a razão que o tenha levado a procurar o serviço. O momento da internação pode ser precioso para desenvolver a motivação para o tratamento, sendo uma ótima oportunidade de orientação tanto individual quanto familiar, respeitando-se os princípios éticos.³

A multicausalidade do fenômeno indica que a abordagem destinada às pessoas que apresentam um consumo problemático de SPAs deve ser também plural, incluindo um leque de alternativas terapêuticas (farmacológicas, motivacionais, familiares, psicoterápicas, mútua ajuda, entre outras) adequadas a sua condição particular.

Para isso, é necessário que os profissionais da saúde auxiliem o paciente não somente no que concerne ao uso de SPAs, mas na recuperação do funcionamento dos aspectos de sua vida que foram prejudicados pelo consumo de drogas. A maioria dos pacientes requer cuidados em longo prazo e apresenta episódios de lapsos e recaídas, que fazem parte do tratamento e que não devem ser vistos como fracasso terapêutico.

USO DE SUBSTÂNCIAS PSICOATIVAS NO BRASIL

O cenário epidemiológico nacional indica redução do consumo de tabaco, mas alta prevalência do consumo de bebidas alcoólicas. Entre as substâncias ilícitas, observa-se não apenas aumento da utilização como também experimentação cada vez mais precoce, o que pode potencializar danos físicos e psíquicos (Tab. 19.1). Além disso, a gravidade das consequências dos episódios de abuso, principalmente os acidentes de trânsito, a exposição a comportamento sexual de risco e atos de violência, contribui para incremento dos danos individuais e coletivos.⁴

Tabela 19.1

Dados do II Levantamento Nacional de Álcool e Drogas

	Uso na vida (%)	Uso nos últimos 12 meses (%)
Maconha	6,8	2,5
Solventes	2,2	0,5
Tranquilizantes	9,6	6,0
Estimulantes	2,7	1,1
Cocaína	3,8	1,7
Crack	1,3	0,7
Alucinógenos	0,9	0,5
Anestésicos	0,5	0,3

Fonte: Laranjeira e colaboradores.⁵

Na população brasileira, em 2012, 50% dos adultos fizeram uso de bebidas alcoólicas nos 12 meses anteriores. A proporção de dependentes atingiu 17%, mostrando percentuais crescentes do problema nos seis anos anteriores. A proporção de fumantes, por sua vez, diminuiu de 20,8 % para 16,9% dos adultos, o que pode ser atribuído a políticas públicas antiuso do tabaco.⁵

Embora haja importantes lacunas na compreensão da etiologia da dependência química, a maioria dos autores concorda que esse é um fenômeno complexo, que envolve aspectos individuais (personalidade, vulnerabilidade biológica, presença de comorbidades, aspectos psicológicos, carga genética), socioculturais (rede social, contexto familiar, laboral, condições de vida, subcultura) e relacionados à substância (ação neurobiológica, potencial dependogênico, disponibilidade, custo, *status*), além de outros que interferem como facilitadores do uso ou protetivos para cada indivíduo.⁶

As drogas de abuso compartilham um mecanismo biológico comum: a propriedade de promover, direta ou indiretamente, a ativação das vias dopaminérgicas mesolímbica e mesocortical, associadas ao prazer, com particular envolvimento da área tegmentar ventral, córtex pré-frontal e *nucleus accumbens*. Essa via final comum da ação das SPAs é denominada “sistema de recompensa cerebral”.⁷

Os mecanismos genéticos, celulares e moleculares relacionados à dependência abrangem diversos processos cognitivos. Por isso, podem mediar a transição entre um padrão de uso não problemático para um padrão de dependência. Esse processo envolve a reprogramação de circuitos neuronais que processam a motivação, os comportamentos de recompensa, a memória,

o condicionamento, a habituação, o funcionamento executivo e o controle inibitório.⁸ Além disso, mecanismos neuroadaptativos contribuem para o desenvolvimento de tolerância e quadros de abstinência, facilitadores do uso compulsivo.

Apesar dos avanços na compreensão do transtorno, estudos têm demonstrado que o uso problemático de SPAs é pouco diagnosticado e tratado.⁹ O período médio entre o primeiro problema decorrente do consumo de SPAs e a primeira intervenção profissional é de cinco anos.¹⁰ A demora para início do tratamento e a terapêutica inadequada pioram o prognóstico e reforçam a ideia de que esses pacientes têm difícil recuperação.⁹

O uso de risco de bebidas alcoólicas pode levar a acidentes, traumas, patologias físicas e psíquicas.⁴ O tabagismo contribui para vários problemas de saúde, incluindo câncer, doenças cardiovasculares e pulmonares.¹¹ O consumo de cocaína associa-se a eventos cardiovasculares, entre eles infarto agudo do miocárdio e acidentes vasculares cerebrais. Essas situações levam os usuários de substâncias a necessitarem de serviços hospitalares.

No Hospital de Clínicas da Unicamp (HC Unicamp), foram entrevistados 348 pacientes admitidos em decorrência de traumas, nos anos de 2008 e 2009. Destes, 25,9% atendiam a critérios de abuso de álcool, e 10,3%, de dependência, de acordo com a Mini International Neuropsychiatric Interview (MINI).^{3,12} O Estudo de Intervenção Breve Oportuna (EIBO), realizado na mesma instituição, avaliou 4.352 pacientes internados consecutivamente e encontrou taxas de abuso/dependência de álcool de 9,8%, e dependência de nicotina, de 16,9%. O consumo de álcool estava associado a sexo masculino, tabagismo, tentativa prévia de suicídio e internação por causa externa, sobretudo acidentes automobilísticos. A dependência de nicotina associou-se a uso de risco de álcool, ser adulto jovem e tentativa prévia de suicídio.¹²

Um ensaio clínico do EIBO, realizado com 237 tabagistas internados, revelou que uma simples orientação, durante a internação, elevou consideravelmente a taxa de cessação, quando comparada à do grupo que não sofreu intervenção, segundo o apurado seis meses após a alta hospitalar (42 e 26%, respectivamente). Esses dados reforçam a ideia de que a internação em um hospital geral representa uma janela de oportunidade para a abordagem do tabagismo e, potencialmente, de outras dependências de SPAs. Além de os pacientes já estarem abstinentes devido à internação e, ao mesmo tempo, distantes dos fatores que incrementam o consumo, a causa da internação, muitas vezes, pode ser relacionada ao uso de SPAs, o que facilita a sensibilização em relação à necessidade de interromper o abuso ou dependência.¹³

O Quadro 19.2 mostra algumas razões para não se fazer o diagnóstico de uso problemático de SPAs, bem como algumas estratégias para aumentar sua detecção.

QUADRO 19.2

Razões de subdiagnóstico e estratégias de detecção do uso de SPAs

Razões para que o diagnóstico não seja feito

- Não saber o que se procura
- Falta de vigilância
- Receio de fazer perguntas
- Não saber o que fazer se confirmado o diagnóstico
- Falta de serviços especializados para onde encaminhar
- Negação ou evasivas do paciente

Estratégias para aumentar o reconhecimento

- Usar perguntas para “desarmar” o paciente
- Avaliar riscos potenciais
- Usar “pistas” psiquiátricas e clínicas
- Conversar com familiares e amigos

QUADROS CLÍNICOS

Síndrome de dependência

Os critérios diagnósticos atuais para dependência aplicam-se a todas as SPAs e enfatizam os aspectos qualitativos, que dizem respeito à relação de prioridade que o sujeito estabelece com a droga, e não apenas quantitativos, como anteriormente. A partir disso, a divisão entre dependência física e psíquica perdeu espaço, e a dependência é vista, hoje, como um fenômeno global.

O Quadro 19.3 mostra os critérios diagnósticos para uso problemático de SPAs de acordo com os dois principais sistemas de classificação diagnóstica em psiquiatria.

QUADRO 19.3

Critérios diagnósticos de uso problemático de SPAs de acordo com a CID-10 e o DSM-5

CID-10	DSM-5
Dependência ■ Forte desejo ou compulsão pelo consumo ■ Dificuldade de controlar o comportamento de uso ■ Sinais/sintomas de abstinência ■ Evidência de tolerância ■ Abandono progressivo de prazeres em favor do consumo ■ Persistência no uso a despeito de consequências nocivas Abuso ■ Padrão de uso que causa dano físico ou mental à saúde	■ Desejo persistente ou esforços malsucedidos de controlar o uso ■ Substância é consumida em maiores quantidades ou por período mais longo que o pretendido ■ Abstinência ■ Tolerância ■ Importantes atividades são abandonadas ou reduzidas em função do uso ■ Uso contínuo apesar da consciência de um problema físico ou psicológico persistente relacionado ao uso ■ Muito tempo é gasto em atividades para obter, utilizar ou se recuperar dos efeitos ■ Fissura ■ Uso resulta em prejuízo no desempenho de funções ■ Uso apesar de problemas interpessoais decorrentes

Fonte: Organização Mundial da Saúde¹⁴ e American Psychiatric Association.¹⁵

Síndrome de abstinência

É um conjunto de sinais e sintomas que ocorre na abstinência total ou na diminuição de consumo de uma SPA, após uso prolongado e/ou em altas doses. O início e o curso do estado de abstinência são limitados no tempo e relacionados à dose da droga consumida imediatamente antes da parada ou redução do consumo.

No contexto do hospital geral, o quadro de síndrome de abstinência (principalmente alcoólica) é frequente, particularmente em procedimentos não eletivos, nos quais o paciente é internado repentinamente e interrompe o consumo de forma brusca. Uma das maneiras de se evitar o problema é detectar o uso problemático de SPAs na anamnese.

Alguns fatores podem ser considerados preditores de quadro de abstinência alcoólica, entre eles:

- história anterior de síndrome de abstinência grave
- alcoolemia alta sem sinais clínicos de intoxicação
- sinais de abstinência mesmo durante uso de álcool
- uso concomitante de tranquilizantes e hipnóticos

AVALIAÇÃO COMPLEMENTAR

Exames laboratoriais

A Tabela 19.2 traz alguns exames de *screening* feitos habitualmente para a detecção de SPAs ilícitas. As amostras de sangue têm possibilidade de detecção quantitativa, sendo, muitas vezes, usadas para a detecção em investigações médico-legais.¹⁶ Exames complementares podem auxiliar na avaliação de disfunções ou danos orgânicos: eletrólitos (Ca, Mg, Na e K), hemograma completo, perfil hepático, coagulograma, albumina e proteína total, ureia e creatinina, ácido úrico, glicemia de jejum, perfil lipídico, amilase, eletrocardiograma (ECG), radiografia de tórax e sorologias para hepatite B e C, HIV e sífilis.

Tabela 19.2

Material de coleta e tempo de detecção de exames toxicológicos de SPAs

Material	Álcool	Cocaína	THC
Sangue	6h	Até 6h	24h
Urina	-	1-3 dias	Até 30 dias
Saliva	6h	Até 6h	24h

Instrumentos de avaliação

Há escalas que podem ser utilizadas para complementar informações da anamnese, em pesquisa e seguimento da evolução dos quadros. As principais aplicações são: triagem, como CAGE,¹⁷ Alcohol Use Disorders Identification Test (AUDIT),¹⁸ Drug Use Screening Inventory (DUSI);^{19,20} diagnóstico ou quantificação de sintomas, entre elas Alcohol Dependence Syndrome (ADS),²¹ Composite International Diagnostic Interview (CIDI),²² Short Alcohol Dependence Data (SADD),²³ Teste de Tolerância de Fagerström;²⁴ avaliação de sintomas de abstinência Clinical Institute Withdrawal Assessment for Alcohol (CIWA-A);²⁵ e planejamento de tratamento, como Addiction Severity Index (ASI)²⁶ e Inventory of Drinking Situations (IDS).²⁷

ITENS IMPORTANTES PARA A FORMULAÇÃO DO CASO

- Diagnóstico: da gravidade do consumo de SPAs, das incapacidades associadas, dos quadros comórbidos físicos e psiquiátricos e história de tratamentos.
- Descrição da personalidade.
- Situação social: conjugal, laboral, lazer, religiosidade e rede de apoio.
- Prognóstico e planejamento terapêutico: expectativas, motivação do paciente e alternativas de tratamento.

ASPECTOS CENTRAIS DA ABORDAGEM

Individualização do tratamento

A individualização do tratamento permite a avaliação contínua da evolução do paciente, possibilitando, ao profissional, adequar as estratégias de abordagem às particularidades do dependente (Quadro 19.4). Isso aumenta a adesão ao tratamento e o sucesso da terapêutica.²⁸

QUADRO 19.4

Aspectos que devem ser considerados na avaliação e no planejamento terapêutico

- Idade de início de consumo de cada SPA
- Padrão de uso (tipo de SPAs utilizadas, frequência e quantidade)
- Substância de escolha
- Último episódio de uso
- Fatores reforçadores e atenuadores do consumo
- Períodos de abstinência
- Manifestação de sintomas de abstinência e tolerância
- Presença de comorbidades psiquiátricas e doenças físicas
- História de tratamento
- Motivação para o tratamento
- Contexto de vida (rede social, situação laboral, aspectos legais)

ABORDAGEM NÃO FARMACOLÓGICA

Entrevista motivacional

Motivação pode ser definida como a probabilidade de uma pessoa aceitar e praticar uma estratégia específica de mudança. Deve ser encarada como um estado de prontidão ou vontade de mudar, que pode flutuar de um momento para outro e de uma situação para outra, podendo ser influenciado por fatores externos.²⁹

A entrevista motivacional (EM) consiste em uma abordagem de aconselhamento visando estimular a mudança de um comportamento potencialmente prejudicial ao indivíduo.²⁹ O terapeuta deve partir de interesses e expectativas do paciente, respeitando sua autonomia e observando seus valores.³⁰ Em vez de propor soluções ou sugestões, a entrevista motivacional oferece condições de crítica, tentando buscar as razões para mudança no paciente.²⁹

É nesse contexto que se desenrolam as questões fundamentais para a avaliação da dependência (Quadro 19.5).

QUADRO 19.5

Questões fundamentais para avaliação de uso problemático de SPAs

- O paciente sabe por que foi solicitada a avaliação?
- Sente-se confortável para conversar neste momento?
- Concorda com a solicitação? Por quê?
- Qual a percepção do paciente sobre o problema?
- Qual o histórico de consumo de SPAs?
- Há história familiar de dependência ou de outros transtornos psiquiátricos?
- Já realizou tratamentos para dependência?
- Há outros transtornos psiquiátricos no momento e/ou na história do paciente?

Existem várias estratégias para se chegar à motivação.³¹ Vejamos algumas adaptadas para uma abordagem de interconsulta em ambiente hospitalar.

Levar em consideração o estágio de prontidão para mudança

Ao primeiro contato com um paciente, rapidamente percebe-se qual sua posição diante do uso que vem fazendo de substâncias. O paciente hospitalizado por um problema de saúde nem sempre estará ávido por falar sobre seu padrão de consumo ou para iniciar um tratamento para dependência. Muitas vezes, ele nem sequer considera a possibilidade de estar com problemas relacionados ao uso de SPAs e não entende bem a razão da avaliação.

Os Estágios de Prontidão para Mudança foram desenvolvidos por Prochaska e Carlo DiClemente,³⁰ quando tentavam compreender por que as pessoas mudam, tanto por si mesmas quanto com auxílio profissional (Tab. 19.3).

Tabela 19.3**Estágios de prontidão para mudança e condutas sugeridas**

Estágio de prontidão	Características	Fala típica do paciente	Tarefa do profissional
Pré-ponderação	Paciente não acredita que o consumo seja um problema.	“Bebo socialmente, paro quando quiser.”	Informar, esclarecer e orientar. Estabelecer relações entre problemas atuais e consumo. Aumentar a percepção do paciente sobre os possíveis riscos caso seu comportamento atual se mantenha.
Ponderação	Ambivalência, não há consciência da dependência mas há percepção de que algo vai mal.	“Acho que passo dos limites às vezes, talvez fosse melhor se eu usasse menos, embora eu não ache que use demais.”	Trabalhar a ambivalência. Evocar razões para mudança. Fortalecer autossuficiência para alterar comportamento.
Determinação	Consciente do problema e suas consequências, mas ainda não alterou o comportamento.	“Acho que não tenho controle do uso e penso que, se tivesse ajuda, seria mais fácil. Mas não sei o que fazer a respeito.”	Ajudar o paciente a escolher qual a melhor linha de ação a ser seguida na busca da mudança. Estimular a mudança. Fornecer opções de tratamento.
Ação	Atitudes de mudança desorganizadas, necessidade de orientação e estruturação.	“Reduzi o consumo e me senti melhor, mas quando os amigos me convidam... aí não resisto, deixo o tratamento de lado.”	Ajudar o paciente a dar passos rumo à mudança. Apresentar opções. Estimular. Treinamento de habilidades.
Manutenção	O paciente modificou sua relação com a substância e mantém-se abstinente. A mudança tem consistência, e a recaída é uma ameaça menos intensa, mas ainda presente.	“Estou há mais de seis meses sem usar, sei o que devo fazer para evitar o uso, mas, em determinados momentos, ainda tenho vontade e tenho medo de não resistir.”	Ajudar o paciente a identificar e a utilizar estratégias de prevenção de recaída. Focalizar em objetivos que o levaram a parar, comparar aspectos do estado atual com a situação em que se encontrava anteriormente.
Recaída	O paciente se manteve abstinente, mas recaiu. Nesse momento, vergonha e desesperança são pensamentos frequentes.	“Sinto-me envergonhado, acho que não mereço confiança, sou fraco. Todo o esforço foi por água abaixo, não tenho mais jeito.”	Orientar que recaída faz parte do tratamento. Renovar os processos de ponderação, determinação e ação.

Abordagens motivacionais eficazes

Algumas abordagens motivacionais devem ser adotadas, sempre guiadas pela já mencionada “escuta reflexiva”. Elas podem gerar respostas bastante favoráveis.³²

Orientação

A orientação deve ser dada à medida que houver espaço para que seja absorvida. Resultados de exames, relação da internação com o uso de SPAs e modalidades de tratamento são informações importantes, desde que respeitem o estágio de motivação atual do paciente.

Remoção de barreiras

Quando o paciente se interessa em dar continuidade a algum tipo de tratamento específico para a dependência, problemas práticos podem ser evidenciados. O profissional pode ter participação

ativa na tentativa de solucioná-los. Estratégias de encaminhamento personalizado e qualificado, além de acompanhamento por telefone, podem mostrar bons resultados.³³

Proporcionar escolhas

O melhor é colocar as possíveis alternativas na forma de sugestões e permitir que o paciente decida qual a mais apropriada para ele.

Atuar na balança

É muito comum o paciente, diante do profissional que o atende, declarar que não vê nada de positivo em ingerir a SPA. É importante que o profissional perceba eventuais benefícios que justifiquem a manutenção do uso (dormir, esquecer problemas), para que os aspectos negativos do problema sejam também evidenciados e abordados de forma honesta.

Feedback

Sintetize o que está sendo dito e devolva para o paciente, usando as palavras dele. Tenha cuidado com as palavras, ao atribuir valores ou usar sinônimos que ele não usou. E fique atento aos seus próprios julgamentos.

Definir objetivos

Antes de percorrer o caminho, o ideal é saber aonde o paciente quer chegar e levar em consideração a posição dos familiares e de sua rede de apoio social. A adequação da proposta às necessidades do paciente é fundamental para o êxito das intervenções.

Prevenção de recaída

A recaída é um momento delicado para o dependente, mas não deve ser vista como o fim da linha. É do aprendizado advindo da recaída que podem se concretizar as habilidades para evitá-la. A prevenção da recaída visa compreender os motivos dos fracassos nas tentativas anteriores (se for o caso) e não repeti-los, além de desenvolver mecanismos para enfrentamento de situações de risco, manejo de fissura e planejamento da nova rotina de vida. Os estágios mais propícios para a utilização dessa estratégia são o de ação e o de manutenção.³⁴

Quadro de vantagens e desvantagens

O uso de SPAs se mantém por aspectos reforçadores (diminuição da ansiedade, distanciamento da ansiedade, prazer pelo efeito psicoativo, entre outros). Se o uso é mantido, esses aspectos são sobressalentes e não podem ser desconsiderados. É importante que o paciente perceba os aspectos positivos e negativos e, com a ajuda do terapeuta, elabore uma reflexão sobre eles.

Para ilustrar o processo, o terapeuta pode utilizar a imagem de uma balança: de um lado colocam-se as vantagens, e de outro, as desvantagens do uso. Esse recurso facilita a reflexão

sobre os motivos para recaída ou abstinência.

Identificação de situações protetoras e provocadoras do uso

Listar e discutir com o paciente as situações cotidianas em que sente que não precisa ou nem lembra de usar e outras em que é muito difícil resistir.

Inventário de habilidades para lidar com situações de risco e estratégias de enfrentamento

Após serem bem identificadas as situações de risco, é importante estudar as características e ferramentas de que o paciente dispõe e de que forma ele pode lidar com cada uma dessas situações, estimulando-o a pedir ajuda a familiares ou amigos próximos.

Modificações no estilo de vida

Observar que, para prevenir recaídas, talvez seja importante uma mudança global dos hábitos de vida. Tentar definir, o mais claramente possível, o que seria, para o paciente, uma proposta de vida mais saudável e o que deveria mudar para que isso ocorresse.

Metas e objetivos

Estimular o paciente a dar as razões de mudança, percorrendo objetivos e ressaltando a capacidade de atingi-los. É importante reforçar a autoeficácia do paciente, as habilidades que tem, as estratégias que definiu para lidar com os riscos de recaída.

Feedback

Sintetize e retorne, para o paciente, o que ele disse, de forma clara e objetiva. Pergunte se ele concorda com o que foi resumido. Ao final, pergunte sobre o que ele gostaria de fazer a respeito de seu consumo de SPAs e em que você poderia ajudá-lo. Pergunte se gostaria de algum tipo de orientação sobre as formas de tratamento disponíveis e relate o quanto essas orientações podem tornar mais fácil a concretização de seus objetivos. Se possível, deixe pronto um encaminhamento ou agendada uma consulta com um serviço que possa atendê-lo após a alta. Disponha-se a responder suas dúvidas e a retornar para revê-lo.³⁵

Para depois da alta hospitalar

Há uma série de possibilidades de serviços para seguimento psiquiátrico pós-alta (Quadro 19.6).³⁶

QUADRO 19.6

Locais de seguimento psiquiátrico pós-alta e suas indicações

	Indicação e manejo
Avaliação psiquiátrica	■ Avaliação diagnóstica ■ Avaliação de comorbidades psiquiátricas ■ Orientação de tratamento
Terapia cognitivo-comportamental	■ Manejo de crenças disfuncionais ■ Reflexão ■ Formas funcionais de adaptação a situações desfavoráveis
Grupos de ajuda mútua (AA e NA)	■ Orientação ■ Ressignificação
Comunidade terapêutica	■ Necessidade de se afastar da rotina para abstinência ■ Destinada a pacientes motivados ■ Apoio e ajuda para motivação ■ Mudanças no estilo de vida partem do paciente
Internação psiquiátrica	■ Necessidade de se afastar da rotina para abstinência ■ Ausência de suporte familiar ■ Risco de síndrome de abstinência ■ Alterações clínicas ■ Comorbidades psiquiátricas
<i>Fonte: Organização Mundial da Saúde.³⁶</i>	

ABORDAGEM FARMACOLÓGICA

A farmacoterapia é um recurso amplamente usado no tratamento da dependência química e, para muitos pacientes, é um dos pontos principais da abordagem.³⁷ Todavia, é fundamental considerar que o uso de fármacos deve estar inserido em uma abordagem mais ampla de tratamento, sendo a medicação um dos elementos terapêuticos.

O ciclo de desenvolvimento da dependência envolve a progressão do reforço positivo para o reforço negativo. O primeiro é mediado principalmente pela liberação de dopamina na área de recompensa cerebral, gerando antecipação dos efeitos prazerosos e intoxicações, associadas à impulsividade. Na presença de fatores de risco para dependência e exposição à substância, podem ocorrer modificações neurobiológicas que levam ao desenvolvimento um quadro compulsivo que envolve tolerância, antecipação, fissura (*craving*), intoxicação, reforço positivo, sintomas de abstinência, reforço negativo e manutenção do uso.³²

Portanto, os objetivos principais do tratamento farmacológico referem-se à abordagem dos sintomas de abstinência, ao manejo de sintomas associados ou que podem levar ao uso (fissura [*craving*], perda de controle, impulsividade, alterações do humor, quadros psicóticos e sintomas ansiosos), além da abordagem de comorbidades psiquiátricas.

ÁLCOOL

As bebidas alcoólicas são amplamente utilizadas no Brasil. Dados comparativos entre o I Levantamento Nacional de Álcool e Drogas (LENAD I) (2006) e o LENAD II (2012) apontam que, embora tenha havido pequena redução na prevalência de uso (de 52 para 50%, respectivamente), houve aumento na quantidade de bebida ingerida em um dia de consumo, elevando em 10% a frequência de consumo de cinco ou mais doses. Além disso, houve clara redução da iniciação precoce de consumo (antes de 15 anos) de 16 para 24% entre meninos e de 8 para 17% em meninas. O consumo em padrão de *binge* na população em geral foi de 45%, em 2006, para 59%, em 2012.⁵

O álcool atua aumentando a ação inibitória gabaérgica, reduzindo a neurotransmissão glutamatérgica, e os efeitos euforizantes reforçadores relacionam-se direta ou indiretamente aos sistemas opioide e canabinoide.³²

A terapia de manutenção da abstinência no alcoolismo deve estar pautada nos seguintes objetivos: diminuição da fissura (*craving*), redução dos efeitos reforçadores, tratamento de eventuais comorbidades clínicas e psiquiátricas, normalização fisiológica e auxílio na retomada de um funcionamento laboral, social e afetivo, respeitando-se os limites do indivíduo.³⁷

O tratamento de primeira linha inclui o uso de naltrexona, acamprosato ou dissulfiram, e, na segunda linha, o topiramato. O uso de benzodiazepínicos restringe-se ao tratamento dos sintomas de abstinência, e de antidepressivos (principalmente ISRSs), aos frequentes quadros depressivos comórbidos.

Naltrexona

A sensação agradável causada pelo etanol é derivada da estimulação indireta de opióides endógenos, causada pela liberação de dopamina no *nucleus accumbens*.³⁸ A naltrexona tem ação antagonista sobre esses receptores opióides, anulando os efeitos prazerosos. Há, dessa maneira, redução do reforço positivo causado pelo etanol, facilitando a redução ou cessação do consumo.³⁸⁻⁴⁰ Essa medicação deve ser usada como adjuvante de um programa de tratamento que inclua aconselhamento e psicoterapia.⁴¹⁻⁴⁴

As principais contraindicações à naltrexona são: hepatite aguda, insuficiência hepática e uso de opióides, já que a naltrexona pode desencadear uma síndrome de abstinência grave nesses pacientes. O monitoramento mensal dos valores de bilirrubina e das transaminases séricas, nos três primeiros meses, e depois, a cada três meses, é importante. Os principais efeitos adversos são náusea (10% dos casos), cefaleia, vertigem, ansiedade e irritabilidade, fadiga, insônia, vômitos e sonolência.⁴⁵

O subgrupo de pacientes com características clínicas favoráveis para a boa resposta ao tratamento com naltrexona associada a psicoterapia é o que apresenta intenso desejo compulsivo de beber e história familiar de alcoolismo entre parentes de primeiro grau. A naltrexona pode ser usada em pacientes que alcançaram a abstinência, que estão tentando atingi-la ou reduzir o consumo excessivo de álcool. É menos eficaz em pacientes que não estão abstinentes no

momento do início do tratamento. A adesão é amplamente aumentada com a formulação injetável (ainda não disponível no Brasil).³²

A posologia recomendada é 50 mg/dia, em dose única, pela manhã. A naltrexona deve ser prescrita depois que a síndrome de abstinência ao álcool for controlada e estabilizada. As interações medicamentosas de maior relevância clínica são dissulfiram e tioridazina.⁴³

Para os pacientes com história de abuso de opioides, é necessário um período mínimo de sete dias de abstinência dessas substâncias. Os pacientes que necessitam de medicamentos para controle de dor devem receber analgésicos não opiáceos. Os pacientes que serão submetidos a cirurgias eletivas e analgésicos contendo opioides no pós-operatório devem ser alertados a suspender a naltrexona pelo menos 72 horas antes do procedimento.

Quanto ao uso em populações especiais, a segurança e a eficácia em adolescentes ainda não estão bem estabelecidas. A naltrexona deve ser evitada em gestantes. Os dados disponíveis são limitados em pessoas com problemas cardíacos graves, e não é necessário ajuste de dose para doença renal de gravidade até moderada. Em geral, também não é necessário ajuste de dose para problemas hepáticos leves e moderados, porém não há estudos sobre o uso em quadros hepáticos severos. É contraindicada em hepatite aguda e falência hepática.³²

Dissulfiram

O dissulfiram é uma substância semelhante às sulfonilureias, utilizado como aversivo ao uso do álcool. O paciente deverá evitar todas as fontes de álcool, e não apenas as provenientes de bebidas alcoólicas, durante dois dias antes do início e até duas semanas após o uso da medicação.

Ele age inibindo a enzima hepática aldeído-desidrogenase (ALDH), que catalisa a oxidação do acetaldeído em acetato. O aumento dos níveis sanguíneos de acetaldeído provoca uma reação aversiva, caracterizada por rubor facial, cefaleia pulsátil, náuseas, vômitos, dor torácica, palpitações, taquicardia, fraqueza, turvação visual, hipotensão arterial, tontura e sonolência. Pacientes mais suscetíveis podem apresentar reações graves, embora raras, como *delirium*, infarto do miocárdio, arritmias cardíacas, insuficiência cardíaca congestiva, depressão respiratória e convulsões.⁴¹ Devido a esses riscos, o dissulfiram deve ser ministrado após consentimento informado e termo assinado pelo paciente e por responsável legal.

Os pacientes que mais se beneficiam com o dissulfiram são os mais velhos, altamente motivados para parar de beber, sem doenças físicas graves, estáveis do ponto de vista social, que necessitam de um auxílio externo para ajudar na sua decisão e estejam participando de programas e estratégias para aumentar a adesão ao tratamento.^{41,42}

As principais contraindicações ao dissulfiram são condições clínicas que aumentem a gravidade da reação do dissulfiram com o etanol (doença vascular cerebral, cardiovascular e pulmonar graves, insuficiência renal, cirrose com hipertensão portal, aterosclerose oculta e diabéticos) e pacientes com déficits cognitivos para os quais seja difícil a compreensão da ação da substância.⁴¹ Não deve ser administrado em pacientes intoxicados por álcool nem em gestantes. Não usar se o paciente estiver tomando metronidazol, amprenavir, ritonavir e sertralina. O uso deve ser muito cauteloso em idosos, em função de comorbidades clínicas.³² O

dissulfiram interfere na biotransformação de vários medicamentos, entre eles fenitoína, diazepam e varfarina.⁴¹

Antes de prescrever o dissulfiram, é importante solicitar provas de função hepática devido a um efeito hepatotóxico idiossincrático raro, porém potencialmente fatal. Além disso, a função hepática deve ser monitorada trimestralmente. A dose habitual é de 250 mg/dia, em dose única, após um intervalo de, pelo menos, 48 horas sem beber. Alguns pacientes podem beneficiar-se com doses de 500 mg/dia. O tempo recomendado de tratamento é de um ano.³⁹ Uma forma alternativa de prescrever o dissulfiram é em situações de risco de consumo de álcool, previsíveis pelo paciente.

Acamprosato

A ação do acamprosato (acetil-homotaurinato de cálcio) consiste na redução de liberação do glutamato, diminuindo as sinapses excitatórias. Com isso, há redução da fissura e do comportamento de busca pelas bebidas alcoólicas. Pacientes tratados com acamprosato têm taxas menores de recaídas e maior tempo de abstinência.³⁷ Ele atua como “álcool artificial”, em função de sua ação que bloqueia receptores glutamatérgicos, mitigando, assim, a hiperexcitabilidade durante a abstinência alcoólica. O esquema de administração pode afetar a adesão, e, embora seja geralmente bem tolerado, diarreia é o efeito colateral mais comum. Não apresenta interações com medicamentos psicotrópicos conhecidos (não inibe nem induz as enzimas hepáticas).

As enzimas hepáticas devem ser monitoradas, sendo o medicamento contraindicado em pacientes com graus avançados de cirrose e na insuficiência renal. Os efeitos colaterais mais comuns são náuseas, vômitos, diarreia, dor abdominal e prurido. Para pessoas com peso inferior a 60 kg, a posologia diária é de quatro comprimidos com 333 mg de acamprosato, perfazendo um total de 1.332 mg diários, divididos em três tomadas (dois comprimidos pela manhã, um à tarde e um à noite). Para pessoas com peso igual ou superior a 60 kg, a posologia diária recomendada é de seis comprimidos com 333 mg de acamprosato, perfazendo um total de 1.998 mg diários, igualmente divididos em três tomadas (dois comprimidos pela manhã, dois à tarde e dois à noite).

Uso em populações especiais: a segurança e a eficácia em adolescentes ainda não estão bem estabelecidas; não usar em gestantes; dados disponíveis limitados em pessoas com problemas cardíacos graves; em pacientes com doença renal de gravidade até moderada, recomenda-se dose de 333 mg, três vezes ao dia, e é contraindicado a doentes com patologia renal grave. Em geral, não é necessário ajuste de dose para problemas hepáticos leves e moderados.³²

NICOTINA

O tratamento farmacológico do tabagismo não deve prescindir de um enfoque mais amplo que inclua a abordagem motivacional e de prevenção de recaída.⁴⁶ Para auxiliar na decisão sobre o tratamento farmacológico, é importante avaliar o grau de dependência da nicotina e a necessidade de utilização de terapia de reposição de nicotina (TRN), por meio do Teste de Fagerström (Quadro 19.7).⁴⁷

QUADRO 19.7

Teste de Fagerström

1. Quanto tempo depois de acordar fuma o primeiro cigarro?	
☐ Nos primeiros 5 minutos	3
☐ 6 a 30 minutos	2
☐ 31 a 60 minutos	1
☐ Mais de 60 minutos	0
2. Tem dificuldade em não fumar em locais em que é proibido?	
☐ Sim	1
☐ Não	0
3. Qual cigarro do dia lhe traz mais satisfação?	
☐ O primeiro da manhã	1
☐ Qualquer outro	0
4. Quantos cigarros fuma por dia?	
☐ 10 ou menos	0
☐ 11 a 20	1
☐ 21 a 30	2
☐ 31 ou mais	3
5. Fuma mais no começo do dia?	
☐ Sim	1
☐ Não	0
6. Fuma mesmo quando está doente?	
☐ Sim	1
☐ Não	0
Total:	

Fonte: Stead e colaboradores.⁴⁷

A pontuação no Teste de Fagerström tem relação com o grau de dependência de nicotina: 0 a 2, muito baixo; 2 a 4, baixo; 5, moderado; 6 a 8, elevado; e 8 a 10, muito elevado. A pontuação a partir de 5 sugere a utilização de TRN. Os Quadros 19.8 e 19.9 contêm informações sucintas sobre o tratamento do tabagismo.

QUADRO 19.8

Tratamento do tabagismo

Produto	Evidência
---------	-----------

Terapia de reposição de nicotina (TRN)*	Todas as formas de TRN podem auxiliar os tabagistas a parar de fumar, quase dobrando a chance de sucesso a longo prazo. Considerada terapêutica de primeira linha
Bupropiona 150 mg	Dobra a chance de sucesso a longo prazo, independentemente de seu efeito antidepressivo. Considerada terapêutica de primeira linha. Considerar efeitos colaterais e restrições de uso.
Vareniclina	Mostrou-se três vezes superior ao placebo, superior à bupropiona e com menos efeitos colaterais. Considerar efeitos colaterais. Uso criterioso em pacientes com história de transtorno mental.
Nortriptilina	Aumenta a chance de sucesso em longo prazo, independentemente de seu efeito antidepressivo. Considerada terapêutica de segunda linha. Considerar efeitos colaterais.
Aconselhamento médico	Aumenta a chance de ter sucesso em parar nos próximos 12 meses. Quanto mais intensivo, mais efetivo.

Fonte: Hughes e colaboradores,⁴⁵ Cahill e colaboradores,⁴⁸ Stead e colaboradores⁴⁹ e Belin e colaboradores.⁵⁰

* Disponíveis no Brasil: adesivos de 21, 14 e 7 mg; goma e pastilhas de 2 e 4 mg

QUADRO 19.9

Orientações para a administração

Produto	Orientações	Principais efeitos indesejáveis
Adesivo de nicotina	Iniciar na noite anterior à data de parada, trocar a cada 24 horas. Colocar em região do corpo sem pelos. Liberação estável de nicotina. A partir de 20 cigarros, iniciar com 21 mg, por 4 semanas; após 1 mês, com 14 mg, e finalizar com 1 mês de 7 mg.	Reação cutânea no local da aplicação e insônia.
Goma e pastilha de nicotina	Utilizar em intervalos de 1 a 2 horas e, no máximo, 20 unidades ao dia. Libera nicotina agudamente. Mais indicada para quem fuma em picos.	Dor à mastigação. Cuidados especiais se o paciente usar prótese dentária (no caso de goma) ou tiver lesões orais.
Bupropiona	Iniciar 14 dias antes da data de parada. Começar com 150 mg/dia pela manhã; após o 3º dia, 150 mg pela manhã e 150 mg à tarde, intervalo de 8 horas; evitar tomada noturna.	Redução do limiar convulsivo, náusea e insônia. Não utilizar em pacientes com história de anorexia nervosa e transtorno bipolar. Uso cuidadoso em caso de hipertensão não controlada.
Vareniclina	Iniciar 7 dias antes da parada. Começar com 0,5 mg 1x ao dia, do 1º ao 3º dia; do 4º ao 7º dia, 0,5 mg, 2x ao dia; do 8º dia até o fim do tratamento, 1 mg, 2x ao dia.	Náusea, cefaleia e insônia. Uso cuidadoso com hipertensos, nefropatas e hepatopatas. Segurança não definida para pacientes com transtorno mental grave.
Nortriptilina	Iniciar 10 a 15 dias antes da data de parada. Começar com 25 mg/dia e otimizar dose a cada 3 dias até 75 mg/dia.	Boca seca, constipação e náusea. Realizar avaliação cardiovascular. É contraindicada a pacientes com transtorno bipolar.

COCAÍNA/CRACK

Na dependência de cocaína e *crack*, a fase de maior fissura (ou *craving*) ocorre nos primeiros dias da abstinência (*crash*). O quadro sintomatológico completo e o tratamento são abordados no Capítulo 20. Após aproximadamente três semanas de abstinência, melhoram os sintomas ansiosos e depressivos. Se houver manutenção de sintomas depressivos e/ou ansiosos, devem ser considerados o diagnóstico de comorbidade e a terapia com inibidores da recaptação de serotonina.

Muitas vezes, o manejo da impulsividade é importante na terapia de manutenção da abstinência de cocaína e *crack*.⁵¹ Para isso, têm sido utilizados o topiramato,⁵² alguns antipsicóticos, como a risperidona,⁵³ ou mesmo inibidores da recaptação de serotonina (ISRSs), como a paroxetina.⁵⁴ Todavia, é importante ressaltar que não há ainda nenhum fármaco aprovado especificamente para o tratamento da dependência de cocaína, o que reforça a relevância da abordagem não farmacológica e a necessidade de estudos visando ampliar o arsenal terapêutico.

OPIÁCEOS

Os opiáceos são obtidos do ópio, podendo ser naturais (quando não sofrem nenhuma modificação) ou semissintéticos, quando são resultantes de processos químicos realizados a partir das substâncias naturais. Opioides são opiáceos totalmente sintéticos, produzidos em laboratórios. Ambos são depressores do SNC e têm efeito analgésico e hipnótico.⁵⁵ Os principais sintomas e o tratamento da intoxicação e da abstinência por opiáceos são abordados no Capítulo 20.

MACONHA E OUTROS DERIVADOS DA CANNABIS

A maconha é a substância psicoativa ilícita mais consumida no mundo.⁵⁶ No Brasil, 8% das pessoas já experimentaram maconha. Quando se avalia o uso nos últimos 12 meses, há maiores taxas entre adolescentes (3,4%) do que entre adultos (2,5%). A porcentagem de uso na vida, em todas as faixas etárias, é amplamente maior para o sexo masculino – em média, três vezes maior do que para o sexo feminino. A taxa de dependência na população brasileira é de 1%.⁵

Seu composto psicoativo principal é o Δ -9 tetra-hidrocanabinol (THC). Se inalado rapidamente, atinge os pulmões e, pela corrente sanguínea, em poucos minutos, cruza a barreira hematoencefálica. Por ser lipossolúvel, o THC acumula-se no tecido gorduroso e pode permanecer por até sete dias no organismo.⁵⁷

Há receptores canabinoides em todo o córtex cerebral, principalmente no sistema límbico (incluindo hipocampo e amígdala), nos gânglios da base, no tálamo e no cerebelo. A maconha tem efeitos euforizantes, pode causar risos imotivados, aumento do desejo sexual e do apetite, aumento da autoconfiança e grandiosidade, da sociabilidade, sensação de relaxamento e loquacidade. Pode, porém, causar ansiedade, irritabilidade, pânico, sensação de despersonalização e desrealização, sonolência, alucinações ou ilusões e diminuição da concentração. Durante a intoxicação, há prejuízo na realização de atividades complexas.

A intoxicação e a abstinência da maconha são abordadas no Capítulo 20. O uso crônico de maconha pode causar prejuízos duradouros e, em alguns casos, permanentes na memória, na capacidade de realizar atividades complexas e na atenção.^{56,57}

Os estudos que enfocam abordagens farmacológicas dos transtornos relacionados ao uso da *Cannabis* são escassos. São utilizados, principalmente, antidepressivos (para síndrome amotivacional) e ansiolíticos (para sintomas de abstinência). Sintomas psicóticos são tratados por antipsicóticos típicos, principalmente haloperidol (1-10 mg/dia), ou atípicos, como risperidona (a partir de 2 mg/dia) ou olanzapina (a partir de 10 mg/dia).⁵⁸

As abordagens não farmacológicas mais eficazes no tratamento da dependência devem ser individualizadas e com olhar multidisciplinar, havendo melhores índices de sucesso em terapias de grupo que enfoquem entrevistas motivacionais e de prevenção de recaída.⁵⁹

ANFETAMÍNICOS

Sintetizadas na década de 1930, inicialmente para tratamento de déficit de atenção/hiperatividade, as anfetaminas são consumidas principalmente por seus efeitos euforizantes e anorexígenos. Há três tipos principais de usuários de anfetaminas: instrumentais (com finalidade de aliviar a fadiga, aumentar a concentração ou diminuir o apetite), recreacionais (efeitos estimulantes são procurados em contextos sociais por subpopulação específica, como jovens em festas *rave*) e crônicos (usuários que consomem para amenizar sintomas de abstinência).³⁷ O manejo da abstinência é abordado no Capítulo 20.³⁷

SOLVENTES

No Brasil, 2% dos adolescentes e 2,2% dos adultos já fizeram uso de solventes na vida, e a dependência é mais rara, atingindo 0,2% da população.⁵ Os solventes são depressores centrais e estão frequentemente relacionados a poliabuso. Seus efeitos intensos e efêmeros estimulam o uso continuado, propiciando o uso nocivo.⁶⁰

O uso de solventes muitas vezes inaugura o histórico de consumo de SPAs do sujeito, iniciando-se na adolescência em contexto grupal. Está associado a padrão de comportamento desviante em adolescentes e à dependência, na idade adulta, de álcool, cocaína, *crack* e opioides.⁶¹

Os efeitos psíquicos do uso de solventes são inicialmente euforia e desinibição, evoluindo para depressão do SNC (confusão mental e desorientação, alucinações). O uso crônico pode causar sintomas clínicos, como neuropatias, pneumonites químicas, náuseas, vômitos, diarreia, hepatite tóxica e até insuficiência renal crônica.³⁷

BENZODIAZEPÍNICOS

No Brasil, 2,5% dos adolescentes e 9,6% dos adultos já utilizaram tranquilizantes.⁵ O uso indiscriminado pode levar a quadros de abuso e dependência: 50% dos pacientes que usam benzodiazepínicos por mais de 12 meses evoluem com síndrome de abstinência.⁶² A retirada progressiva dos benzodiazepínicos deve ser realizada independentemente do uso abusivo ou do aparecimento da síndrome de dependência, uma vez que os sintomas de ambos tendem a ser muito sutis no usuário de benzodiazepínicos.³⁷

O tratamento consiste na retirada gradual da medicação, que deve ser negociada com o paciente para maior sucesso terapêutico. A retirada de 25% da dose por semana é prática comum, mas pode ser mais lenta caso o médico avalie ser necessário. Outra alternativa é a substituição por um benzodiazepínico de meia-vida mais longa que o habitualmente usado. O mais usado é o diazepam, por ter absorção rápida e meia-vida bastante longa devido ao seu metabólito, desmetildiazepam. Propranolol e buspirona podem também ser usados no combate a sintomas da abstinência, como ansiedade, tremores, palpitações.⁶³

O médico deve estar atento a eventuais comorbidades, sobretudo depressão. O manejo da insônia, caso ocorra, pode ser realizado com higiene de sono e medicamentos hipnóticos, como o zolpidem.⁶³

IMPLANTAÇÃO DE UNIDADE PSIQUIÁTRICA LIVRE DO TABACO

A prevalência de tabagismo entre indivíduos com transtorno mental é superior à da população em geral.⁶⁴ Em função disso, a abordagem do tabagismo deve ser incluída no atendimento dos pacientes com transtorno mental, e a internação psiquiátrica pode representar uma oportunidade para isso.

A Unidade Psiquiátrica do HC Unicamp tornou-se ambiente livre da fumaça do tabaco há vários anos. O Quadro 19.10 descreve os passos que foram dados para tanto.⁶⁵

QUADRO 19.10

Processo de implantação de ambiente livre de tabaco na Unidade Psiquiátrica do HC Unicamp

Atividades	Objetivo	Resultado observado
Sensibilização da equipe assistencial	Levantar temores e entraves à proposta segundo a visão dos profissionais.	Sugestões de como manejar a “insistência” do paciente e a agressividade. O tabagismo na equipe foi também posto em questão.
Levantamento da prevalência de tabagismo entre os pacientes	Levantar o número de tabagistas internados durante 30 dias, visando estimar a quantidade de TRN necessária.	26% de tabagistas. Considerando essa taxa e a permanência média de internação, estimou-se uma utilização mensal média de 100 unidades de goma, 45 de adesivos de 21 mg e 5 de adesivos de 14 mg.
Realização de grupos motivacionais com pacientes e orientação aos familiares	Sensibilizar e orientar sobre a impossibilidade de uso de cigarro durante a internação e os potenciais benefícios.	Realizados por profissionais do ambulatório de tabagismo e da enfermaria. Houve maior receptividade por parte dos pacientes e familiares do que esperávamos.
Treinamento para utilização da TRN	Treinar a equipe, principalmente os médicos-residentes de psiquiatria, a utilizar TRN.	No período de junho de 2008 a maio de 2009, para 35 pacientes, foram utilizadas 1.252 unidades de goma, 550 de adesivos de 21 mg e 55 de adesivos de 14 mg.

Fonte: World Health Organization.⁶⁵

Nesse processo, não houve aumento nas ocorrências de agressividade e de recusa de internação. Houve crescente conscientização por parte da equipe e de familiares. Um benefício não planejado pelo programa que trouxe grande satisfação à equipe de implantação foi a iniciativa exitosa de cessação de tabagismo empreendida por alguns profissionais da unidade. Após um ano do início da implantação, foram contatados, por telefone, os pacientes que estiveram internados no serviço naquele período, com o objetivo de avaliar o padrão de consumo de cigarros após a internação, sendo obtidos os seguintes resultados: 31% mantiveram o padrão, 27% reduziram, 10% tinham parado de fumar, mas recaíram, e 27% estavam sem fumar desde a alta.

Os dados descritos indicam a validade de estratégias de abordagem do tabagismo em pacientes com transtornos mentais em espaços de tratamento, notadamente durante a internação psiquiátrica.

REFERÊNCIAS

1. Organização Mundial da Saúde. Neurociência do uso e da dependência de substâncias psicoativas. São Paulo: Roca; 2006.
2. Escohotado A. Historia de las drogas. Madrid: Alianza; 1995.
3. Oliveira KD, Baracat EC, Lanaro R, Eugeni C, Ricci E, Rabello MS, et al. Alcohol and brief intervention for trauma victims. *Rev Col Bras Cir.* 2015;42(4):202-8.
4. Azevedo RCS. Usuários de Cocaína e AIDS: um estudo sobre comportamentos de risco [tese]. Campinas: Universidade Estadual de Campinas; 2000.
5. Laranjeira R, Pinsky I, Caetano R, Mitsuhiro SS, Madruga CS. II Brazilian National Alcohol and Drugs Survey.UNIAD: Unidade de Pesquisas em Álcool e Drogas. São Paulo: Universidade Federal de São Paulo; 2012.
6. Oliveira KD, Azevedo RCS. Criminal behaviour in users of psychoactive substances who began treatment. *Social Crimonol.* 2015;3:121.
7. Goldstein RZ, Volkow, ND. Drug addiction and its underlying neurobiologicalbasis: neuroimaging evidence for the involvement of the frontalcortex. *Am J Psychiatry.* 2002; (159):1642-52.
8. Koob GF, Volkow ND. Neurobiology of addiction: a neurocircuitry analysis. *Lancet Psychiatry.* 2016;3(8):760-73.
9. Turner BJ. Gaps in addressing problem drinking: overcoming primary care and alcohol treatment deficiencies. *Curr Psychiatry Rep.* 2009;11(5):345-52.
10. Cleary PD, Miller M, Bush BT, Warburg MM, Delbanco TL, Aronson MD. Prevalence and recognition of alcohol abuse in a primary care population. *Am J Med.* 1988;85(4):466-71.
11. Rigotti NA, Clair C, Munafò MR, Stead LF. Interventions for smoking cessation in hospitalised patients. *Cochrane Database Syst Rev.* 2012;(5):CD001837.
12. Botega NJ, Mitsuushi GN, Azevedo RCS, Lima DD, Fanger PC, Mauro MLF, et al. Depression, alcohol use disorder and nicotine dependence among patients at a general hospital.*Rev Bras Psiquiatr.* 2010;32(3):250-6.
13. Azevedo RC, Mauro ML, Lima DD, Gaspar KC, da Silva VF, Botega NJ. General hospital admission as an opportunity for smoking-cessation strategies: a clinical trial in Brazil. *Gen Hosp Psychiatry.* 2010;32(6):599-606.
14. Organização Mundial de Saúde. Manual de classificação estatística internacional de doenças e problemas relacionados à saúde. São Paulo: OMS; 1995.
15. American Psychiatric Association. Diagnostic and statistical manual of mental disorders: DSM-5. 5th ed. Washington: APA; 2013.
16. Edwards G, Gross MM. Alcohol dependence: provisional description of a clinical syndrome. *Br Med J.* 1976;1(6017):1058-61.
17. Mayfield D, Mcleod G. The CAGE questionnaire. *Am J Psychiatry.* 1974;131:1121-3.
18. Babor TF, de la Fuente JR, Saunders J, Grant M. Audit: the alcohol use disorders identification test. Geneva: WHO; 1992.

19. Tarter R. Evaluation and treatment of adolescents substance abuse: a decision tree method. *Am J Drug Alcohol Abuse*. 1990;16(1-2):1-46.
20. De Micheli D, Formigoni MLOS. Screening of drug use in a teenage Brazilian sample using DUSI. *Addict Behav*. 2000;25(5):683-91.
21. Skinner HA, Allen BA. Alcohol dependence syndrome: measurement and validation. *J Abnorm Psychol*. 1982;91(3):199-209.
22. Robins LN, Wing J, Wittchen HU, Helzer JE, Babor TF, Burke J, et al. The Composite International Diagnostic Interview. An epidemiologic Instrument suitable for use in conjunction with different diagnostic systems and in different cultures. *Arch Gen Psychiatry*. 1988;45(12):1069-77.
23. Raistrick D, Dunbar G, Davidson R. Development of a questionnaire to measure alcohol dependence. *Br J Addict*. 1983;78(1):89-95.
24. Fagerström KO. Measuring degree of physical dependence to tobacco smoking with reference to individualization of treatment. *Addict Behav*. 1978;3(3-4):235-41.
25. Stuppaeck CH, Barnas C, Falk M, Guenther V, Hummer M, Oberbauer H, et al. Assesment of the alcohol withdrawal syndrome. *Addiction*. 1994;89(10):1287-92.
26. McLellan AT1, Kushner H, Metzger D, Peters R, Smith I, Grissom G, et al. The fifth edition of the addiction severity index. *J Subst Abuse Treat*. 1992;9(3):199-213.
27. NB Figlie NB, Laranjeira R. case management applied to the treatment of alcohol dependence. *Rev Bras Psiquiatr*. 2004;26(Supl I):63-7.
28. Jungerman FS, Laranjeira R. Entrevista motivacional: bases teóricas e práticas. *J Bras Psiquiatr*. 1999;48(5):197-207.
29. Sales C, Figlie NB. Entrevista motivacional. In: Diehl A, Cordeiro DC, Laranjeira R. Dependência química: prevenção, tratamento e políticas publicas. Porto Alegre: Artmed; 2011. p. 267-77.
30. Prochaska JO, Diclemente CC. Transtheoretical therapy: toward a more integrative model of change. *Psychol Psychother-T*. 1982;19(3):276-88.
31. Padilha VM, Azevedo RCS. Intervention for patients with psychoactive substance use disorders, starting from psychiatric emergency care: follow-up study after 30 and 90 days. *J Addict Behav Ther Rehabil*. 2015;4:3.
32. Castro AL, Baltieri D. The pharmacologic treatment of the alcohol dependence. *Rev Bras Psiquiatr*. 2004;269(suppl 1):43-6.
33. Marlatt GA. Prevenção de recaída: racionalidade teórica e visão geral do modelo. In: Marlatt GA, Gordon JR. Estratégias de manutenção no tratamento de comportamentos aditivos. Porto Alegre: Artmed; 1993.
34. Azevedo RCS, Oliveira VF. Dependência de substâncias psicoativas: conceitos básicos. In: Botega NJ, organizador. Prática psiquiátrica no hospital geral: interconsulta e emergência. 3. ed. Porto Alegre: Artmed; 2012.
35. Brasil. Ministério da Saúde. Secretaria Executiva. Coordenação Nacional de DST e AIDS. A Política do Ministério da Saúde para atenção integral a usuários de álcool e outras drogas. Brasília: MS; 2003.

36. Organização Mundial da Saúde. Neurociência do uso e da dependência de substâncias psicoativas. São Paulo: Roca; 2006.
37. Stahl SM, Grady MM. Stahl's illustrated: substance use and impulsive disorders. New York: Cambridge University; 2015.
38. Samet JH, O'Connor PG, Stein MD. Clínicas médicas da América do Norte: abuso de álcool e de outras drogas. Rio de Janeiro: Interlivros; 1997.
39. Krystal JH, Cramer JA, Krol WF, Kirk GF, Rosenheck RA; Veterans Affairs Naltrexone Cooperative Study 425 Group. Naltrexone in the treatment of alcohol dependence. *N Engl J Med*. 2001;345(24):1734-9.
40. Banzato CEM, Loper AD, Azevedo RCS. Naltrexona na dependência de álcool: ensaio clínico aberto. *J Bra Psiquiatr*. 2004;53(2):134-8.
41. Laranjeira RR, Nicastri S. Abuso e dependência de álcool e drogas. In: Almeida OP, Dractu L, Laranjeira RR. Manual de psiquiatria. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan; 1996.
42. Schepis TS, Adinoff B, Rao U. Neurobiological processes in adolescent addictive disorders. *Am J Addict*. 2008;17(1):6-23.
43. O'Malley SS, Jaffe AJ, Chang G, Rode S, Schottenfeld R, Meyer RE, et al. Six-month follow-up of naltrexone and psychotherapy for alcohol dependence. *Arch Gen Psychiatry*. 1996;53(3):217-24.
44. Azevedo RCS. Abordagem do tabagismo: estratégia para redução de fator de risco. In: Li Min L, Fernandes PT, Martins S, Massaro A. AVC científico: neurociências e acidente vascular cerebral. São Paulo. Plêiade; 2009.
45. Hughes JR, Stead LF, Hartmann-Boyce J, Cahill K, Lancaster T. Antidepressants for smoking cessation. *Cochrane Database Syst Rev*. 2014;(1):CD000031.
46. Fagerström KO. Measuring degree of physical dependence to tobacco smoking with reference to individualization of treatment. *Addict Behav*. 1978;3(3-4):235-41.
47. Stead L, Silagy C, Lancaster T, Mant D, Fowler G. Nicotine replacement therapy for smoking cessation. *Cochrane Database Syst Rev*. 2002;(4):CD000146.
48. Cahill K, Stead LF, Lancaster T. Nicotine receptor partial agonists for smoking cessation. *Cochrane Database Syst Rev*. 2012;(4):CD006103.
49. Stead LF, Bergson G, Lancaster T. Physician advice for smoking cessation. *Cochrane Database Syst Rev*. 2008;(2):CD000165.
50. Belin D, Mar AD, Dalley JD, Robbins TW, Everitt BJ. High impulsivity predicts the switch to compulsive cocaine-taking. *Science*. 2008;320(5881):1352-55.
51. Kampman KM, Pettinati H, Lynch KG, Dackis C, Sparkman T, Weigley C, et al. A pilot trial of topiramate for the treatment of cocaine dependence. *Drug Alcohol Depend*. 2004;75(3):233-40.
52. De La Garza R 2nd, Newton TF, Kalechstein AD. Risperidone diminishes cocaine induced craving. *Psychopharmacology (Berl)*. 2005;178(2-3):347-50.
53. Patkar AA, Gottheil E, Berrettini WH, Hill KP, Thornton CC, Weinstein SP. Relationship between platelet serotonin uptake sites and measures of impulsivity, aggression, and craving

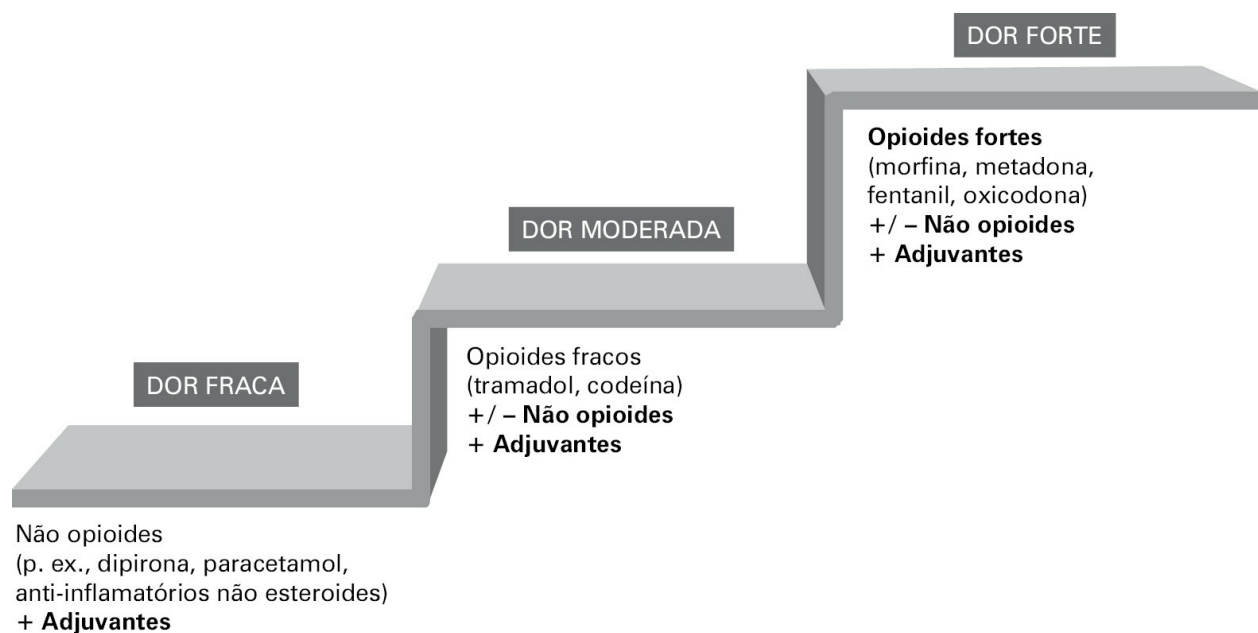
- among African-American cocaine abusers. *Am J Addict*. 2003;12(5):432-47.
54. Baltieri DA, Strain EC, Dias JC, Scivoletto S, Malbergier S, Nicastri S, et al. Diretrizes para o tratamento de pacientes com síndrome de dependência de opióides no Brasil. *Rev Bras Psiquiatr*. 2004;26(4):259-69.
 55. Elkashef A, Vocci F, Huestis M, Haney M, Budney A, Gruber A, et al. Marijuana neurobiology and treatment. *Subst Abus*. 2008;29(3):17-29.
 56. Ashton CH. Pharmacology and effects of cannabis: a brief review. *Br J Psychiatry*. 2001;178:101-6.
 57. McRae AL, Budney AJ, Brady KT. Treatment of marijuana dependence: a review of the literature. *J Subst Abuse Treat*. 2003;24(4):369-76.
 58. Jungerman FS. The effectiveness of a brief intervention for cannabis users [thesis]. São Paulo; 2005.
 59. Gossop M, Trakada K, Stewart D, Witton J. Reductions in criminal convictions after addiction treatment: 5-year follow-up. *Drug Alcohol Depend*. 2005;79(3):295-302.
 60. Noto AR, Galduróz JCF, Nappo AS, Carlini EA. Levantamento nacional sobre o uso de drogas entre crianças e adolescentes em situação de rua nas 27 capitais brasileiras. São Paulo: CEBRID; 2003.
 61. Longo LP, Johnson B. Addiction: Part I: Benzodiazepines- side effects, abuse risk and alternatives. *Am Fam Physician*. 2000;61(7):2121-8.
 62. Seivewright N. Theory and practice in managing benzodiazepine dependence and misuse. *J Sub Misuse*. 1997;3(3):170-7.
 63. Jochelson K. Smoke-free legislation and mental health units: the challenges ahead. *Br J Psychiatry*. 2006;189:479-80.
 64. Azevedo RCS, Higa CMH, Lema JLR, Miranda FZ, Botega NJ. Implementation of a smoke-free psychiatric unit in a general hospital. *Rev Bras Psiq*. 2010;32(2):197-8.
 65. World Health Organization. Cancer: WHO's pain ladder [Internet]. Geneva: WHO; c2011 [capturado em 15 fev. 2017]. Disponível em: <http://www.who.int/cancer/palliative/painladder/en/>.

APÊNDICE

Dor e dependência de opioides

A dor é sempre uma experiência subjetiva, e a relação entre lesão tecidual e dor não é uniforme, nem previsível. A dor sempre tem um componente psíquico, o qual é modulado por cultura, história e contexto de vida, aprendizagem, personalidade e estado emocional de cada indivíduo. O efeito desse componente se faz presente no chamado comportamento de dor, como também na base algumas dores crônicas e na transição de dor aguda para crônica. Estratégias psicológicas para o tratamento combinado da dor são cada vez mais utilizadas.

A Organização Mundial da Saúde¹ sugere a padronização do tratamento analgésico com base em uma escala de três degraus, de acordo com a intensidade da dor que o paciente apresenta (Figura a seguir).



Escada analgésica da OMS.

Fonte: Com base em World Health Organization.²⁹

Os analgésicos devem ser prescritos em intervalos regulares de tempo, de acordo com sua meia-vida plasmática. A dose subsequente deve ser administrada antes que o efeito da dose anterior tenha terminado. Os analgésicos empregados e as respectivas doses devem ser suficientes para aliviar a dor, com um mínimo de efeitos colaterais.

Os opioides devem ser vistos como um recurso terapêutico eficaz contra as dores moderadas e fortes. O uso dessa classe de analgésicos pode ser discutido sob três principais perspectivas: uso sob prescrição, uso não médico e uso indevido por profissionais da saúde.

Frequentemente, pacientes com dor não recebem tratamento adequado, pois não são medicados com analgésicos opioides. Esse problema é frequentemente encontrado na prática clínica em nosso país. A falta de prescrição decorre, em parte, de temores relacionados a

hiperalgesia, *overdose*, tolerância e dependência. É importante que o clínico prescreva adequadamente os opioides, a fim de que o paciente possa melhorar sua sensação de bem-estar.

Em contrapartida, há os casos de uso indevido. Estudos realizados nos Estados Unidos indicam que 70% das pessoas já usaram opioides alguma vez na vida; 28%, nos últimos 12 meses; e 17% usaram opioides sem prescrição. Entre as que usaram opioides, apenas 50% foram alertadas sobre risco de dependência. Não contamos com estudos semelhantes no Brasil.

Tem havido crescimento nas taxas de abuso, *overdose*, mortalidade e visitas aos prontos-socorros por causa de opioides. Abuso pode ocorrer em até 30% dos pacientes que usam esse tipo de analgésico, tanto para automedicação da dor quanto para obtenção de euforia. As taxas de dependência são menores e muito variáveis, com mediana de 4,5%. Há maior risco com os opioides de ação e liberação rápidas.

Vários elementos se combinam para ocasionar o abuso e a dependência de opioides entre profissionais da saúde, entre os quais onipotência “estimulada” desde a graduação, autoprescrição, disponibilidade, história pessoal ou familiar de dependência, problemas emocionais, estresse no trabalho, fadiga crônica e ausência de medo em relação ao uso de injetáveis. Além disso, a vergonha e o mecanismo psicológico de negação retardam a busca de auxílio para combater a dependência. Há, também, de parte dos colegas de trabalho, uma “conspiração do silêncio” (percebe-se que algo está errado, mas ninguém vai a fundo para ajudar). É por isso que o assunto deveria ser discutido desde a graduação, visando à detecção precoce e à redução do estigma.

Taxas superiores de dependência são relacionadas a

- idade mais jovem
- uso de fármacos sem prescrição
- uso de psicofármacos
- antecedente de uso de heroína ou outras SPAs
- sexo masculino
- dor subjetiva em diferentes regiões corporais
- morbidade psiquiátrica, sobretudo ansiedade e depressão
- profissionais da área da saúde
- estresse psicossocial
- tabagismo
- raça branca
- transtorno de estresse pós-traumático

A abstinência de opioides pode surgir em 24 horas após a última dose, com pico de frequência entre 2 e 3 dias e remissão em 10 a 14 dias. O quadro clínico e o tratamento da abstinência são abordados no corpo deste capítulo.

Em síntese, enfatizamos que:

- A dor é sempre subjetiva. Deve ser avaliada em um contexto amplo e sempre tratada com eficiência.

- O paciente deve receber o melhor esquema analgésico disponível, incluindo, quando necessário, opioides.
- A escada analgésica da OMS é útil. No entanto, em caso de dor aguda de moderada a intensa, já podemos iniciar pelo segundo ou terceiro degrau.
- A dependência de opioides ocorre em uma porcentagem pequena de pacientes. É reduzida quando são considerados os principais fatores de risco.
- Se houver dependência, há formas de abordagem com boa resposta.
- Deve haver uma ampliação da discussão, desde a graduação, sobre os prós e contras da utilização de opioides em analgesia, incluindo-se o risco de dependência em profissionais da saúde.
- Há necessidade de mais estudos nacionais sobre esse tema.

REFERÊNCIA

World Health Organization. Cancer: WHO's pain ladder [Internet]. Geneva: WHO; c2011 [capturado em 15 fev. 2017]. Disponível em: <http://www.who.int/cancer/palliative/painladder/en/>.

LEITURAS RECOMENDADAS

- Alves HNP, Surjan JC, Nogueira-Martins LA, Marques ACPR, Ramos SP, Laranjeira RR. Abuso de fármacos anestésicos pelos anesthesiologistas Rev Bras Anesthesiol. 2005;62(3):380-6.
- Alves HNP. Perfil clínico e demográfico de médicos com dependência química. Rev Assoc Med Bras. 2005;51(3):139-43.
- Barry CL, Kennedy-Hendricks A, Gollust SE, Niederdeppe J, Bachhuber MA, Webster DW, et al. Understanding American's views on opioid pain reliever abuse. Addiction. 2016;111(1):85-93.
- Boscarino JA, Rukstalis M, Hoffman SN, Han JJ, Erlich PM, Gerhard GS, et al. Risk factors for drug dependence among outpatients on opioid therapy in a large US health-care system. Addiction. 2010;105(10):1776-82.
- Kerr-Correa F, Andrade AG, Bassit AZ, Boccuto NMVF. Uso de álcool e drogas por estudantes de medicina da Unesp. Rev Bras Psiquiatr. 1999;21(2):95-100.
- Kraychete DC, Siqueira JTT, Garcia JBS. Recomendações para uso de opioides no Brasil. Dor. 2013;14(4):295-300.
- Minozzi S, Amato L, Davoli M. Development of dependence following treatment with opioid analgesics for pain relief: a systematic review. Addiction. 2013;108(4):688-98.
- Nascimento DCH, Sakata RK. Dependência de opioide em pacientes com dor crônica. Dor. 2011;12(2):160-5.



Substâncias psicoativas: emergências psiquiátricas

Marcelo Ribeiro
Danisa Cardoso Graceli
Ronaldo Laranjeira

Entre os atendimentos mais comuns no pronto-socorro do hospital geral, estão as complicações decorrentes do uso de álcool e drogas. O plantonista deve estar sempre preparado para avaliar e tratar esses casos, levando em consideração a grande frequência de comorbidades clínicas ou psiquiátricas associadas. Deve, ainda, prevenir uma evolução desfavorável para sintomas de síndrome de abstinência, complicações clínicas, *delirium* ou até mesmo óbito. O atendimento em serviços de emergência pode ser o primeiro passo para que pacientes que fazem uso problemático de substâncias psicoativas procurem um tratamento adequado. Este capítulo aborda o quadro clínico e o tratamento de quadros psiquiátricos agudos decorrentes do uso de substâncias psicoativas.

As complicações relacionadas ao uso de álcool e outras drogas nas salas de emergências são um fato recorrente na atualidade.¹⁻³ A identificação do uso de substâncias é crucial para o tratamento adequado desses indivíduos. Entretanto, o uso de substâncias psicoativas (SPAs) é subdiagnosticado.⁴ As dificuldades aumentam quando os pacientes têm alterações da consciência ou do comportamento, o que pode sugerir presença de outros tipos de transtornos psiquiátricos ou orgânicos.⁵⁻⁷

A abordagem e o manejo adequados do uso de SPAs, durante ou após a passagem por uma unidade de emergência, têm-se mostrado efetivos para reduzir tanto o uso da substância quanto a ocorrência de futuras admissões em unidades de emergência.⁴ Desse modo, é importante o médico saber para onde encaminhar esses pacientes após os atendimentos. É essencial, também, que o seguimento se dê em serviços especializados em dependência química.⁸ Os clínicos devem aproveitar todas as oportunidades para explorar questões motivacionais, de maneira empática e assertiva, como enfatizado no Capítulo 19.^{4,7} Estudos têm demonstrado que a intervenção breve na emergência é aplicável e eficaz.⁸

ÁLCOOL

O álcool é a substância psicoativa mais utilizada em nossa sociedade. Tem ampla aceitação cultural, diversas apresentações e rituais de consumo e fácil acesso ao usuário.^{7,9,10} Em usuários crônicos, apresenta maior incidência de complicações relacionadas ao uso (continuado e/ou abusivo) ou à interrupção do uso dessa substância (síndrome de abstinência).^{6,11}

As alterações sistêmicas, sobretudo as hepáticas, devem ser sempre consideradas e investigadas nos indivíduos com história de uso prolongado e intenso, não importando o motivo pelo qual chegaram ao pronto-socorro. Tais indivíduos, com frequência, se alimentam de forma precária, podendo estar desidratados e com baixa imunidade.^{11,12} Além disso, relatos de vômitos são comuns, o que torna os pacientes mais propensos a descompensações hidreletrolíticas e do equilíbrio acidobásico. Traumas repetidos e acidentes também são mais frequentes, em comparação à população em geral.¹⁰

Intoxicação aguda

A intoxicação aguda varia de uma embriaguez leve a anestesia, coma, depressão respiratória e, mais raramente, morte.¹³⁻¹⁵ Há alterações variáveis do comportamento e do humor, como excitação e alegria, irritabilidade, agressividade, depressão e ideação suicida.^{7,14} Cognitivamente, ocorrem lentificação do pensamento e prejuízo da concentração, do raciocínio, da atenção e do julgamento.^{14,16} Há também maior suscetibilidade para acidentes automobilísticos, agressões físicas, suicídios e homicídios e outros acidentes.^{6,14}

A Tabela 20.1 apresenta os níveis plasmáticos de álcool (mg%) e as alterações fenomenológicas relacionadas. A velocidade com que a bebida é ingerida, a ingestão prévia de alimentos, os fatores ambientais e o desenvolvimento de tolerância aos efeitos do álcool interferem nessa relação.¹⁷

Tabela 20.1

Fenomenologia relacionada aos níveis plasmáticos de álcool (mg%)*

Euforia/excitação Alterações leves de atenção	0,03
Alterações leves de coordenação	0,05
Ataxia	0,1
Confusão Diminuição da concentração Náuseas e vômitos	0,2
Hipotermia Disartria Amnésia	0,3
Anestesia Coma*** Morte	≥ 0,4**

* A velocidade com que a bebida é ingerida, a ingestão prévia de alimentos, os fatores ambientais e o desenvolvimento de tolerância aos efeitos do álcool interferem nessa relação.

** Entre 0,6 e 0,8 mg%, a intoxicação alcóolica costuma ser fatal.

*** Quadro clínico habitual: hipotermia, frequência respiratória superficial, reflexos diminuídos ou aumentados, palidez cutânea, retenção ou incontinência urinária, entre outros sintomas.

A intoxicação aguda é passageira, pois o organismo metaboliza cerca de 0,015 mg% de álcool/hora.¹⁶ Na maioria dos casos, é necessário apenas assegurar a interrupção do consumo de álcool pelo indivíduo e lhe proporcionar um ambiente seguro e livre de estímulos, onde possa passar algumas horas. Diálogos objetivos, esclarecedores e realistas situam e acalmam o indivíduo.

Um exame físico cuidadoso deve ser feito logo na admissão, a fim de detectar sinais de complicações, como aspiração brônquica, crises hipertensivas, traumatismos cranioencefálicos (TCEs) e sinais de cronicidade ou comorbidades (hepatomegalia, desnutrição, infecções). Se possível, deve-se obter também a história do uso de álcool e outras drogas (pregressa e atual), a presença de patologias crônicas (clínicas e psiquiátricas), o uso de medicamentos e as queixas apresentadas pelo paciente. Pacientes comatosos, no entanto, requerem abordagem de emergência (Quadro 20.1).

QUADRO 20.1

O paciente comatoso: aplicável a intoxicações por qualquer substância

O paciente inconsciente é uma emergência médica e requer abordagem especial. As intoxicações são apenas um dos fatores causais. As condutas se iniciam mesmo diante da inexistência de confirmação do diagnóstico.

Primeiro passo: *sinais vitais e acesso intravenoso*

- Se estiverem ausentes, iniciar reanimação cardiorrespiratória imediatamente.
- Infusão de soro fisiológico 0,9% ou Ringer lactato em pacientes desidratados/hipotensos.

Segundo passo: *vias aéreas livres*

- Retificação da cabeça.
- Remoção de corpos estranhos da garganta.
- Ausculta cardiorrespiratória.
- Respiração artificial/intubação orotraqueal, se necessário.
- Se a intubação for desnecessária: posicionar o paciente em decúbito lateral (a fim de evitar a aspiração de vômitos) e monitorar o padrão respiratório.

Terceiro passo: *circulação adequada*

- Aparelho de monitoramento cardíaco.
- Parada cardíaca/fibrilação: massagem/desfibrilador.

Quarto passo: *exame físico rápido*

- Condições da pupila/nistagmo.
- Marcas de agulha na pele.
- Odor do hálito.
- Palpação do fígado.
- Investigação de traumas (observar otorrinorrágia).

Quinto passo: *exames laboratoriais*

- Testes toxicológicos (10 mL de sangue).
- Hemograma, eletrólitos, metabólitos e glicemia (30-40 mL de sangue).
- Gasometria arterial.

Sexto passo: *trato urinário*

- Sondagem com cateter de Foley.
- Testes toxicológicos (50 mL de urina).

Sétimo passo: *infusão intravenosa de antídotos (quando há suspeita)*

- **Naloxona** (0,4 mg [adultos] e 0,01 mg/kg [crianças], infusão lenta).
Repetir 1 ou 2 vezes a cada 3 minutos, se não houver resposta.
Melhora da frequência respiratória = intoxicação opioide.
- **Flumazenil** (0,3 mg em 15 segundos [adultos])
Repetir 0,3 mg 1/1 min, até a melhora do nível de consciência (dose máxima: 2 mg). Melhora = intoxicação por benzodiazepínicos.

- **Fisostigmina** (1-4 mg [adultos] infusão lenta), caso haja suspeita de intoxicação por anticolinérgicos (taquicardia, pele/boca secas, rash, etc.).

Oitavo passo: *exame de ponta de dedo*

- Hipoglicemia: glicose 50% 50 mL intravenosa.

Nono passo: *lavagem gástrica e carvão ativado*

- Intoxicações orais ocorridas há menos de seis horas (ou até 12 horas no caso da fenciclidina).
- Reposição dos líquidos perdidos por via intravenosa.

O exame de ponta de dedo informa de maneira fácil e rápida a glicemia e indica a necessidade de reposição de glicose. Indivíduos com história nutricional adequada, tendo feito um uso abusivo e isolado, não necessitam de administração prévia de tiamina. Já usuários crônicos, com sinais de desnutrição e hábitos alimentares precários, necessitam de avaliação laboratorial completa para verificar sinais e sintomas de abstinência de álcool.

Transtornos amnésicos alcoólicos (*blackouts*)

Os *blackouts* são episódios transitórios e lacunares de amnésia retrógrada (para fatos e comportamentos ocorridos a partir de graus variados de intoxicação alcoólica). Podem ocorrer em associação com o beber excessivo, em pessoas dependentes ou não, embora se acredite que apareçam nas fases tardias da dependência. Não há explicação consensual da causa. Teorias atuais levam a acreditar que haja relação entre a diminuição da serotonina e a desregulação dos neurorreceptores excitatórios na gênese dos *blackouts*.¹⁸

Intoxicação alcoólica patológica

A intoxicação patológica é caracterizada por comportamento destrutivo, impulsivo, desorganizado, sem foco ou objeto específico, desencadeado pelo uso de pequenas doses de álcool. Tal condição tende a ser seguida de exaustão e amnésia lacunar para o episódio.¹⁸ No entanto, o diagnóstico é raro, devendo ser estabelecido de forma criteriosa. Além disso, pode haver dificuldade em diferenciá-la de outras patologias, como epilepsia, em especial a de lobo temporal, *delirium tremens*, distúrbio do comportamento após traumatismo craniano, quadros dissociativos e transtornos da personalidade antissocial e histriônica.^{18,19} O álcool pode desencadear também comportamentos agressivos, mas, na maioria dos casos, há concordância com níveis sanguíneos elevados (intoxicação aguda).¹⁶

Não há tratamento específico para a intoxicação patológica. Na fase aguda, é necessário conter o comportamento agressivo do paciente, por meio de métodos sedativos e de contenção (ver Cap. 13).^{16,18,19}

Síndrome de abstinência do álcool

A síndrome de abstinência do álcool (SAA) tem início algumas horas (4 a 12) após a diminuição ou a parada do consumo de álcool, que leva à queda de seus níveis plasmáticos.^{6,14} Os sintomas da SAA encontram-se no Quadro 20.2. O tempo e a intensidade do uso são diretamente

proporcionais à gravidade do quadro.^{6,11} Além disso, a condição tem curso flutuante e autolimitado.¹³

QUADRO 20.2

Sinais e sintomas de abstinência de álcool

Físicos

- Tremores (variáveis desde finos até generalizados por todo o corpo)
- Fraqueza
- Náuseas e vômitos
- Aumento da temperatura corporal
- Aumento da frequência cardíaca
- Aumento da pressão arterial
- Hipotensão ortostática
- Sudorese
- Cefaleia
- Caimbras
- Tontura
- Convulsões

Afetivos

- Irritabilidade
- Ansiedade
- Inquietação
- Depressão

Cognitivos

- Diminuição do campo vivencial
- Ilusões
- Alucinações (visuais, auditivas e táteis)
- Pesadelos

A síndrome evolui de maneira ordenada, progressiva e evidente. Apresenta um estágio inicial não complicado, marcadamente autonômico e disfórico, que pode se associar a episódios convulsivos tônico-clônicos generalizados, evoluir para um quadro confusional (*delirium tremens*) ou ambos.^{6,19} Convulsões podem ocorrer em 10% dos dependentes de álcool, mas pode haver outras etiologias, como TCE, alterações metabólicas (p. ex., hipomagnesemia, hipoglicemia e hiponatremia) e epilepsia.⁶

É importante observar, também, que sinais e sintomas de abstinência podem ser mascarados pelo uso concomitante de medicamentos, como betabloqueadores e benzodiazepínicos (BDZs). Além disso, patologias de base ou complicações concomitantes, como hipoglicemia, são capazes de exacerbar ou provocar quadros confusionais semelhantes.¹¹

Pacientes admitidos em unidade de emergência após um trauma devem ser investigados quanto ao risco de desenvolvimento de síndrome de abstinência. A falha em reconhecer tais sintomas confunde o diagnóstico dos danos provenientes do trauma, piora o prognóstico e pode levar ao óbito.⁶ O Quadro 20.3 indica as principais condições clínicas que devem ser investigadas no diagnóstico diferencial da SAA.¹³

QUADRO 20.3

Principais condições clínicas que devem ser investigadas no diagnóstico diferencial da síndrome de abstinência do álcool

- Infecções (pneumonia, meningite, encefalite)
- Traumatismo craniocéfálico, hematoma subdural
- Encefalopatia hepática, má nutrição
- Efeitos adversos com outros medicamentos
- Com convulsões: tumor, alterações hidroeletrolíticas, traumatismo craniano
- Com *delirium tremens*: além das já citadas, investigar outras causas de *delirium*

Fonte: Laranjeira e colaboradores.¹³

Síndrome de abstinência não complicada

O sintoma de abstinência mais comum é o tremor, acompanhado de irritabilidade, náuseas e vômitos.⁹ Esses sintomas aparecem algumas horas após a diminuição ou a parada da ingestão e costumam ser observados no período da manhã. Os tremores têm magnitude variável. Algumas pessoas, no entanto, referem apenas tremores internos. Esses tremores se tornam mais acentuados com atividade motora, extensão dos membros superiores, protrusão da língua, bem como estresse emocional. Outros sintomas que acompanham os tremores estão relacionados à hiperatividade autonômica, como taquicardia, aumento da pressão arterial, sudorese, hipotensão ortostática e febre ($< 38^{\circ}\text{C}$).¹⁹

Cerca de 90% dos casos não evoluem para além de um quadro efêmero, brando e marcado por tremores, insônia, agitação e inquietação psicomotora, com autorresolução entre 5 e 7 dias, podendo levar menos tempo.¹⁹ Apenas uma pequena parte dos usuários ingere quantidades de álcool por um período de tempo suficiente para desenvolver uma sintomatologia mais intensa e completa, conforme exposto no Quadro 20.2.

Durante a anamnese e o exame físico, deve-se ter em mente que o indivíduo em abstinência é um usuário crônico e pode utilizar o álcool ainda que em detrimento de seu autocuidado. Torna-se, desse modo, suscetível a complicações como desnutrição (anemia, déficit vitamínico, hipoglicemia) e descompensações hidroeletrolíticas (desidratação, hipopotassemia, hiponatremia e hipomagnesemia). Além disso, a ação direta do álcool sobre a medula óssea e/ou o estado nutricional deficitário comprometem sua imunidade, expondo-o a diversos agentes infecciosos. Os aparelhos gastrointestinal, circulatório e respiratório e o sistema nervoso central (SNC) devem, portanto, ser cuidadosamente investigados. Com isso, alguns exames laboratoriais de rotina devem sempre ser solicitados, como é abordado no Capítulo 19.

Tratamento de suporte

Os objetivos principais do tratamento da síndrome de abstinência do álcool são alívio dos sintomas, prevenção do agravamento do quadro com convulsões e *delirium*, vinculação e engajamento do paciente no tratamento da dependência.^{6,13}

Cerca de 80% dos usuários crônicos apresentam deficiência de tiamina, devido à baixa absorção desse elemento e à dieta insuficiente. Por isso, todos os pacientes abstinentes devem receber 300 mg de tiamina, intramuscular, por 7 a 15 dias, para prevenir complicações neurológicas.

Deve-se sempre medir a glicemia do paciente. Sempre que a correção de glicose for necessária, a aplicação intramuscular de 100 mg de tiamina deve precedê-la, uma vez que suas reservas são agudamente depletadas pela administração da glicose e podem precipitar a encefalopatia de Wernicke (Quadro 20.4).¹⁹ A administração via parenteral é justificada pelo prejuízo da absorção oral nos primeiros dias da SAA.^{7,13} Após esse período, pode ser administrada tiamina oral na dose de 300 mg/dia.

QUADRO 20.4

Síndrome de Wernicke-Korsakoff

A síndrome de Wernicke-Korsakoff está associada ao déficit de tiamina no organismo. Qualquer patologia que altere o processo de obtenção de tiamina pelo organismo (síndrome de má absorção, anorexia, hiperêmese gravídica, obstrução gastrointestinal, alimentação parenteral prolongada, tireotoxicose e hemodiálise) pode desencadear a síndrome. O consumo excessivo e prolongado de álcool é a principal causa. O álcool inibe a absorção ativa da tiamina no intestino; além disso, em geral, há prejuízo na ingestão de alimentos pelos usuários acometidos.

A metabolização da glicose pelas células nervosas depende da tiamina pirofosfato, coenzima da qual a tiamina é precursora. O consumo de glicose pelos neurônios diminui em até 60% com a deficiência da vitamina. Como resultado, há lesões focais do tálamo, do hipotálamo, dos corpos mamilares e do assoalho do quarto ventrículo, bem como degeneração do *vermis* cerebelar e neuropatia periférica. Histologicamente, encontram-se células inflamatórias, hemorragias petequiais e perda neuronal.

A **encefalopatia de Wernicke** tem início abrupto e se manifesta por meio de confusão mental (o sintoma mais comum), distúrbios oculomotores e ataxia cerebelar. O diagnóstico pode ser estabelecido sem a presença dessa tríade. Os distúrbios oculomotores incluem desde nistagmo até paralisia ocular completa. A ataxia pode preceder em dias a confusão mental. É uma das causas metabólicas a serem aventadas quando há necessidade de esclarecimento do coma. A ausência de resposta clínica clara em 48 a 72 horas sugere mau prognóstico. A mortalidade é 17%, e, embora a tríade desapareça em torno de um mês após o tratamento, a síndrome amnésica (Korsakoff) acompanha ou segue-se à encefalopatia de Wernicke em 80 a 85% dos casos.

Por ser uma situação emergencial, deve-se administrar 300 mg de tiamina intravenosa até a oftalmoplegia desaparecer. O desaparecimento da ataxia pode levar dias ou semanas. Uma das causas de falha do tratamento é a hipomagnesemia. Sulfato de magnésio (1-2 mL em solução de 50%) deve ser administrado, por via intramuscular, concomitantemente.

A **síndrome de Korsakoff** é classicamente descrita como uma condição crônica na qual ocorre um predomínio de amnésia retrógrada (até vários anos antes do início da doença) e anterógrada. O quadro clínico em geral aparece com o curso crônico da encefalopatia de Wernicke ou após *delirium tremens*. Em alguns casos, pode progredir de forma insidiosa. No entanto, a confabulação, considerada o sintoma típico, nem sempre está presente. Podem ocorrer alterações de comportamento sugestivas de lesão no lobo frontal (apatia, inércia, perda de *insight*). O paciente sente dificuldade em ordenar os eventos e preenche lacunas mnêmicas com falsas lembranças, ou em parte verdadeiras, mas em sequências erradas (confabulação).

Diferentemente do que ocorre com a encefalopatia de Wernicke, o quadro clínico da síndrome de Korsakoff não se reverte após a reposição de tiamina. O tratamento, às vezes, requer hospitalização, e o diagnóstico diferencial com demência alcoólica nem sempre é fácil. A clonidina (0,3 mg, 2 vezes ao dia) tem sido associada a melhora discreta da memória recente. Propranolol (20 mg/kg/dia) também tem sido utilizado no controle dos sintomas agudos. No entanto, infelizmente, nenhum desses tratamentos parece ser muito eficaz.

Fonte: Marques e Ribeiro.¹⁹

Os níveis glicêmicos e os eletrólitos também devem ser investigados e corrigidos prontamente,¹⁹ uma vez que podem provocar quadros confusionais semelhantes a *delirium tremens*, convulsões e comprometimento do funcionamento cardíaco. Outro procedimento básico é o aporte hídrico endovenoso e nutricional. A maioria dos abstinentes responde a esses procedimentos.

Tratamento farmacológico

Para aqueles que não respondem aos procedimentos de suporte, o tratamento farmacológico deve ser instituído. O objetivo da farmacoterapia é o controle dos sintomas por meio de um sedativo com tolerância cruzada com o álcool, aliviando os sintomas e prevenindo complicações. De todos os sedativos disponíveis, os BDZs são os mais seguros e eficazes.⁷ Além disso, têm ação anticonvulsivante e preventiva eficaz para *delirium tremens*.

Os BDZs de meia-vida longa (diazepam e clordiazepóxido) são os mais indicados, pois protegem o paciente por mais tempo.^{13,19} No entanto, em indivíduos cuja função hepática se

encontra comprometida (hepatopatas e idosos), é preferível utilizar BDZs que passem apenas pela conjugação hepática, como o lorazepam (1-4 mg a cada 6-8 horas).

No caso de o paciente estar internado, podem ser usados diazepam (10-20 mg, por via oral, a cada hora), clordiazepóxido (50-100 mg, por via oral, a cada hora) ou lorazepam (2-4 mg, por via oral, a cada hora).

Todos devem ser administrados até que a sedação leve seja atingida. A dose eficaz obtida é então dividida em 3 a 4 administrações diárias e retirada gradualmente ao longo de uma semana. A via oral é sempre a mais indicada. O diazepam e o clordiazepóxido têm absorção intramuscular errática. O mesmo não ocorre com o lorazepam, mas o mercado brasileiro não dispõe de sua apresentação em ampolas.

Quando a via intravenosa é a única possível, deve-se evitar a administração no soro fisiológico ou glicosado, pois a estabilidade dos BDZs nessas soluções é baixa. A melhor alternativa é a injeção direta e lenta do diazepam (10 mg a cada 4 minutos), a fim de evitar o risco de parada respiratória.¹³

A sedação branda alivia parcialmente os sintomas, mas expõe o paciente ao risco de convulsões e *delirium tremens*. A supersedação aumenta o risco de quedas, diminui o reflexo da tosse, acumula secreção pulmonar e atrasa a reabilitação do paciente. Portanto, as doses devem ser bem mensuradas, a fim de evitar os extremos.¹¹

Quanto à dieta, o melhor é optar pela leve se for aceita pelo paciente. É importante que aqueles com quadro de confusão mental permaneçam em jejum, devido ao risco de aspiração e consequentes complicações respiratórias, o que pode levar a óbito. Nesses casos, deve-se utilizar a hidratação intravenosa com 1.000 mL de solução glicosada 5%, acrescida de 20 mL de NaCl, 20%, e 10 mL de KCl, 19,1%, a cada 8 horas, lembrando sempre da reposição de tiamina antes dessa hidratação.¹³

Convulsões relacionadas à abstinência alcoólica

Cerca de 10 a 15% dos usuários de álcool apresentam crises convulsivas, tipo grande mal, durante seus períodos de abstinência.⁶ O consumo de álcool diminui o limiar convulsivo, mas, para isso, tem de ser utilizado por longos períodos para que as crises sejam desencadeadas (estima-se que, pelo menos, cinco anos de uso contínuo). Em mais de 90% dos casos, as convulsões ocorrem entre 7 e 38 horas após a última dose, com pico após 24 horas, e estão associadas a evolução para formas graves de abstinência.¹³ Metade das tomografias de crânio de pacientes acometidos apresenta algum tipo de lesão estrutural, e um terço deles apresenta sinais neurológicos focais ao exame físico. Além disso, um terço dos pacientes evolui para um quadro de *delirium tremens*.¹³

Outras causas de convulsão, como hipomagnesemia, hipoglicemia, alcalose respiratória e aumento do sódio intracelular, traumatismo com hemorragia intracraniana e história prévia de epilepsia ou lesão do SNC, estão associadas ao desencadeamento de convulsões alcóolicas e devem ser investigadas.⁶

O aparecimento de convulsões indica que os sintomas de abstinência serão graves. O paciente deve ser internado, e o tratamento farmacológico com BDZs, prontamente instituído. Esses fármacos aumentam o limiar convulsivo e protegem o paciente de recorrências. Utiliza-se diazepam, 10 a 30 mg/hora, por via oral, até atingir sedação leve.^{12,13} Prescreve-se também sulfato de magnésio, 1 g, intramuscular, a cada 6 horas, durante dois dias. Convulsões múltiplas podem ser tratadas com fenitoína, 100 mg, três vezes ao dia. No momento do atendimento, a convulsão pode ser interrompida com a administração intravenosa de uma ampola de diazepam, 10 mg (lenta, em 4 minutos, com suporte ventilatório). Pacientes com história prévia de epilepsia devem manter os medicamentos já utilizados.¹³

Delirium tremens

O *delirium tremens* caracteriza-se por um quadro confusional agudo, flutuante e autolimitado. Inicia-se cerca de 72 horas após a última dose de álcool e dura de 2 a 6 dias. Apenas uma pequena parte dos abstinentes evolui para esse estágio.¹¹ É uma condição de urgência médica, associada a riscos significativos de morbidade e mortalidade, mas com opções rápidas e eficazes de tratamento.¹¹

A sintomatologia habitual, em graus variados de intensidade, caracteriza-se por estado confusional flutuante, com estreitamento do campo vivencial e marcado por desorientação espaço-temporal, prejuízo da memória de fixação (fatos recentes), desagregação do pensamento, alucinações e delírios que se somam aos sinais e sintomas de abstinência iniciais (tremor, inquietação/agitação psicomotora, insônia, sudorese, febre leve, taquicardia, excitação autonômica pronunciada).¹³ O humor é lábil, marcado por estados de ansiedade e temor, podendo haver depressão, raiva, euforia ou apatia.

O quadro alucinatorio clássico é visual, envolvendo insetos e pequenos animais, mas pode haver também formas táteis, com sensação de insetos e animais caminhando pelo corpo do paciente, e formas auditivas, que vão de ruídos e sons primários a vozes de natureza persecutória. Os pacientes com quadros ilusionísticos tomam objetos por animais (p. ex., o equipo do soro é uma serpente) e identificam pessoas de forma errada.

A internação sempre é indicada para os casos de *delirium tremens*. Os pacientes devem passar pela mesma avaliação diagnóstica e receber o mesmo tratamento de suporte descrito nos casos não complicados. O quadro piora, com frequência, ao entardecer ou em ambientes pouco iluminados, fenômeno conhecido por *sundowning*.¹⁹ Por isso, devem permanecer em um ambiente desprovido de estímulos e iluminado. Em casos de agitação e confusão extremas, é necessária a contenção mecânica, a fim de protegê-los de autoagressões (ver Cap. 13).

O tratamento medicamentoso segue o mesmo esquema dos BDZs: diazepam, na dose de 60 mg/hora, por via oral, até a sedação leve, ou lorazepam, na dose de 12 mg/hora, por via oral, até a sedação leve.

Todavia, quando houver predomínio de sintomas alucinatorios e agitação psicomotora, pode-se administrar haloperidol, 5 mg, por via intramuscular. O haloperidol diminui o limiar convulsivo e, por isso, deve ser utilizado após a administração de pelo menos 20 mg de

diazepam. O uso da clorpromazina não é indicado, por diminuir bastante o limiar convulsivo. Sedativos com ação anticolinérgica (p. ex., prometazina) podem desencadear ou piorar quadros de *delirium* e, por isso, são contraindicados.¹³

Alucinoze alcoólica

A alucinoze alcoólica tem uma característica peculiar: o paciente não apresenta rebaixamento do nível de consciência e evolui sem alterações autonômicas evidentes; entretanto, apresenta quadro alucinatório predominantemente auditivo, com sons do tipo cliques, rugidos, cantos ou vozes. As alucinações podem também ser táteis ou visuais. Além disso, os pacientes apresentam sensações de medo, agitação ou ansiedade decorrentes de tais sintomas. Pode ocorrer no período de 48 horas após diminuição, aumento ou interrupção da ingestão de etílicos. O tratamento é feito com haloperidol, 5 mg/dia,¹³ devendo-se observar a presença de outros sinais sugestivos de SAA.¹²

COCAÍNA E CRACK

A cocaína é um estimulante e anestésico local, extraída da planta *Erythroxylon coca*, utilizada principalmente por via intranasal, injetável ou pulmonar (*crack*). A via escolhida interfere na quantidade e na qualidade dos efeitos provocados pela substância, bem como no potencial para causar dependência (Tab. 20.2). Além disso, cada via expõe os usuários a riscos relacionados ao modo de consumo (Quadro 20.5).

Tabela 20.2
Perfil farmacocinético da cocaína considerando as vias de administração

Tipo de substância	Concentração de cocaína	Via de administração	Disponibilidade no plasma (%)	Velocidade de início dos efeitos	Concentração máxima no plasma*	Duração dos efeitos
Folhas de coca (infusão)	0,5-1,5%	Mascada ou infusão ou oral	20-30%	Lenta	60min	30-60min
Cloridrato de cocaína	12-75%	Tópica ou intranasal Intravenosa	20-30% 100%	Relativamente rápida Rápida	5-10min 30-45s	30-60min 10-20min
Sulfato de cocaína	40-85%	Inalatória	70-80%	Muito rápida	8-10s	5-10min
Cristais de cocaína	30-80%	Inalatória	70-80%	Muito rápida	8-10s	5-10min

Fonte: Com base em Lizasoain e colaboradores.²⁰

QUADRO 20.5

Complicações relacionadas ao consumo de cocaína conforme a via de administração

- Qualquer via
- Hipertensão
 - Arritmias cardíacas
 - Isquemia do miocárdio
 - Infarto agudo do miocárdio
 - Miocardiopatias
 - Dissecção ou ruptura da aorta
 - Cefaleias
 - Convulsões
 - Acidente vascular cerebral
 - Hemorragia intracraniana
 - Hemorragia subaracnóidea
 - Isquemia mesentérica
 - Insuficiência renal aguda secundaria a rabdomiólise
 - Hipertermia
 - Hipoglicemia
 - Acidose láctica
 - Hipocalemia
 - Hipercalemia
- Via inalatória
- Broncopneumonias
 - Hemorragia pulmonar
 - Edema pulmonar
 - Pneumomediastino
 - Pneumotórax
 - Asma
 - Bronquite
 - Bronquiolite obliterante
 - Depósito de resíduos
 - Presença de corpo estranho
 - Lesões térmicas

- Esofagite
- Doenças sexualmente transmissíveis

Via intranasal

- Broncopneumonias
- Necrose de septo nasal
- Rinite
- Sinusite
- Laringite

Via intravenosa

- Endocardite bacteriana
- Embolia pulmonar
- Aneurismas micóticos
- HIV/aids
- Doenças sexualmente transmissíveis

Por sua condição ilícita, a cocaína e o *crack* vendidos nas ruas não têm controle de qualidade e apresentam todo tipo de adulterantes e métodos de refino e alcalização duvidosos, aumentando ainda mais a vulnerabilidade dos usuários.¹⁶ Outro problema é que os usuários, com frequência, fazem uso concomitante de cocaína e depressores do SNC (álcool, BDZs, opiáceos), com o intuito de equilibrar os efeitos estimulantes da droga. Portanto, a dependência de álcool e BDZs deve ser sempre considerada entre esses indivíduos.^{3,7}

A cocaína estimula o SNC por meio do bloqueio da recaptação de dopamina, noradrenalina e serotonina (monoaminas) nas sinapses. O aumento da concentração desses neurotransmissores é responsável tanto pelos efeitos euforizantes da substância²¹ quanto pelos adversos, como ftofobia (devido à dilatação da pupila), aumento da pressão arterial, sudorese, inquietação motora, entre outros,⁹ além do comportamento de fuga ou luta (*fight-or-flight behavior*), deixando os usuários mais alertas e mais predispostos a atitudes impulsivas e hostis.²¹

No entanto, com o uso crônico, o SNC se torna tolerante aos efeitos euforizantes da cocaína, devido à inibição da secreção de monoaminas, à redução dos receptores pós-sinápticos (*downregulation*) e ao aumento da metabolização de neurotransmissores na sinapse. O resultado é a diminuição dos níveis de monoaminas na fenda sináptica, provável elo neurobiológico entre o uso prolongado de cocaína e o surgimento dos sintomas de abstinência da substância. Além disso, ocorre um processo de sensibilização do SNC, o *kindling*, relacionado à ocorrência de convulsões, *craving* e sintomas paranoides nos usuários.²²

Na presença de etanol, a cocaína é transesterificada por esterases hepáticas em cocaetileno, com toxicidade superior em relação ao álcool e à cocaína isolados, sobretudo para o fígado e o coração.²⁰ Além disso, há aumento do tempo de atividade da cocaína²³ e, conseqüentemente, maior risco de morte súbita pelo uso da substância.²⁰

Características particulares do *crack*

O *crack* é a apresentação da cocaína-base, em forma de pedra, utilizada via pulmonar por meio de cachimbos ou cigarros (em geral misturados com tabaco ou maconha, podendo ser chamados mesclado, pitilho, zirrê ou craconha).²⁴ A associação com a maconha é comum, justificada pelos usuários como uma forma de atenuar os efeitos indesejáveis do *crack*, como a paranoia.²⁵ O uso associado com álcool também é frequente, com a justificativa de atenuação de efeitos

indesejáveis e prolongamento dos efeitos prazerosos, provavelmente o efeito farmacológico do cocaetileno.²⁵

As características neurobiológicas que dão ao *crack* maior potencial de adição e que são determinantes para o padrão compulsivo de seu uso nas formas inalatória e intravenosa são:²⁴

- Via de administração pulmonar: a difusão é rápida e com efeitos imediatos (em 5 s) e mais intensos do que as outras vias.²¹
- A duração dos efeitos é muito curta, levando o usuário a fazer uso frequente.²⁶
- O quadro de *craving* é mais elevado, tornando os sintomas mais proeminentes e a busca pela droga mais frequente.²⁷
- A cocaína na forma de *crack* tem efeitos mais euforizantes do que as outras vias, mesmo em concentrações equivalentes, por ser liberada amplamente na circulação pulmonar e atingir rapidamente o cérebro.²⁸

O consumo dessa substância aumentou consideravelmente nos últimos 20 anos, iniciando-se em idades cada vez mais precoces. A droga teve grande difusão pelo País e por todas as classes sociais e está associada a comportamentos de risco e situações de violência, com padrão de uso compulsivo.²⁹

As consequências clínicas do consumo de *crack* vão desde queimaduras nas pontas dos dedos e dos lábios e lesões nas vias aéreas até danos cardíacos e cerebrais e morte.³⁰ Também é importante salientar o grande risco de contaminação desses usuários por doenças sexualmente transmissíveis²⁹ e de quadro de desnutrição e emagrecimento, devido à falta de apetite provocada pelo uso da droga.¹⁵

Intoxicação aguda e overdose

A intoxicação aguda por cocaína geralmente cursa com ansiedade, agitação psicomotora e persecutoriedade, bem como sintomas autonômicos, como tremores, espasmos musculares, sudorese, midríase, taquicardia, aumento da pressão arterial e da temperatura corporal, *angina pectoris* e infarto agudo do miocárdio.⁶

A *overdose* leva à falência de um ou mais órgãos, em decorrência do aumento da atividade autonômica do organismo.³¹ Ela pode acometer qualquer tipo de usuário (crônicos, eventuais ou iniciantes). A dose letal é influenciada por diversos fatores, como tolerância, presença de patologias de base (p. ex., insuficiência coronariana), grau de pureza da cocaína, entre outros.³²

O tratamento começa por uma avaliação clínica completa, com monitoramento das funções vitais e rápida obtenção da glicemia. A dor precordial, muito frequente, costuma ser sintoma de infarto agudo do miocárdio em apenas 3% dos casos.³⁰ O paciente deve ser examinado, avaliado com eletrocardiograma e observado. Funções renal e hepática, hemograma completo, eletrólitos e glicemia devem ser solicitados. Outros exames, como creatinofosfoquinase (CK-MB) e tomografia computadorizada de crânio, devem ser solicitados quando houver suspeitas clínicas que os justifiquem.³³

A sedação com BDZs é o tratamento de escolha para os casos de inquietação aguda, com predomínio de ansiedade. Pacientes com sintomas psicóticos ou que apresentam quadros de agitação e/ou heteroagressividade importantes devem ser tratados com neurolépticos (p. ex., haloperidol, 5 mg, por via intramuscular), com repetições de dose, se necessário.³⁰

Síndrome de abstinência e fissura (*craving*)

Os sintomas da síndrome de abstinência da cocaína são caracterizados por três fases: a fase inicial, denominada *crash* e caracterizada por fadiga, insônia e depressão, com duração de 1 a 2 dias; a fase de retirada, com quadro de disforia e ansiedade; e a fase de extinção.¹⁴ Tais sintomas desaparecem ao longo de dias ou semanas. Não há, no entanto, medicação específica para o tratamento da síndrome de abstinência de cocaína, sendo, nesse caso, sintomático¹⁴ e baseado na presença de comorbidades, se presentes.

O fenômeno mais peculiar detectado no uso crônico de estimulantes é o *craving*, ou fissura, um desejo súbito e intenso de utilizar a substância, em meio a uma sensação de mal-estar e desconforto físico e psíquico.²¹ Alguns indivíduos chegam a procurar serviços de emergência em busca de alívio medicamentoso para os sintomas de abstinência. Não há, no entanto, uma abordagem terapêutica que suprima tais sintomas como um todo.³⁰ Em geral, o ambiente hospitalar e uma abordagem empática e reasseguradora do médico podem ser suficientes. Caso contrário, BDZs ou neurolépticos em doses baixas podem ser utilizados.³ Além disso, o médico responsável deve encaminhar esses pacientes para tratamento ambulatorial ou internação em ambiente protegido.

Transtornos psiquiátricos

As complicações psiquiátricas agudas são o principal motivo de procura por atendimento de urgência entre usuários de cocaína.⁷ Em geral, prevalecem os quadros ansiosos, principalmente com sintomas de mal-estar e pânico.²¹ Alguns pacientes apresentam quadros paranoides transitórios, restritos ao período de intoxicação.⁷

Quadros psicóticos são mais comuns em usuários de *crack* do que naqueles que usam cocaína por outras vias.²¹ A cocaína, porém, é um fator de risco para o início de transtornos psicóticos em indivíduos predispostos.⁹ Pessoas com transtorno bipolar podem desencadear quadros de mania após o consumo da substância ou utilizá-la para potencializar os sintomas da doença. Além disso, o uso crônico de cocaína evolui com sintomas depressivos em boa parte dos indivíduos.³⁴

A sedação com BDZs é uma opção para os casos de inquietação aguda, com predomínio de ansiedade. Pacientes com sintomas psicóticos ou que apresentam quadros de agitação ou heteroagressividade devem ser tratados com neurolépticos (haloperidol 5 mg por via intramuscular), com repetições de dose, se necessário. Os neurolépticos diminuem o limiar convulsivo e devem ser administrados com cautela. BDZs com boa ação sedativa (midazolam, 15 mg, por via intramuscular) podem ser associados.²¹

CLUB DRUGS

A expressão *club drugs* se refere a um grupo de drogas que se tornaram populares a partir da década de 1990 e que são sobretudo usadas em *raves* ou danceterias com o intuito de incrementar a interação social e aumentar a estimulação sensorial.^{35,36} Entre o grupo de usuários, essas drogas recebem o nome de “bala”.³⁷ Essas drogas são administradas principalmente via oral e, em geral, são combinadas com outras substâncias, como álcool e outras drogas, o que resulta em um elevado risco de efeitos colaterais graves e *overdose*.³⁵

As principais e mais utilizadas *club drugs* são o *ecstasy* (MDMA), o gama-hidroxibutirato (GHB), a quetamina, a metanfetamina e o Rohypnol.^{35,38} O MDMA tem similaridades estruturais com a anfetamina e o alucinógeno mescalina; o GHB e a quetamina são agentes anestésicos; a metanfetamina é um psicoestimulante de longa duração; e o Rohypnol é um BDZ com poder hipnótico e sedativo.³⁵ Por causa dessas diferenças, os tratamentos discutidos para cada substância diferem na abordagem e na conduta.

O aparecimento dessas drogas nos últimos anos e o crescimento de seu uso demonstram a necessidade de o profissional da saúde familiarizar-se com as mudanças constantes no padrão de uso e na diversidade de drogas, além de vislumbrar novas formas de intervenções terapêuticas e medicamentosas.^{37,39}

MDMA (*ecstasy*)

O MDMA (3,4-metilenodioximetanfetamina, *ecstasy*) tem sido a droga estimulante mais utilizada.^{37,40} Em geral, é vendido como comprimidos de cores variadas, com impressões de ícones populares ou letras. Uma grande proporção deles é adulterada com substâncias como cafeína, dextrometorfano, pseudoefedrina, LSD, entre outras.^{38,41}

A ingestão de MDMA aumenta a liberação de serotonina, dopamina e noradrenalina e diminui seu metabolismo por meio da inibição da monoaminoxidase.³⁵ Os efeitos da intoxicação leve incluem taquicardia, sudorese, amplificação sensorial (descrita como aumento na intensidade de luz, sons, cheiros, gosto e sensibilidade emocional) e diminuição da fadiga e da fome. Esses efeitos farmacológicos fazem essas drogas serem populares em *raves*.^{38,39}

As intoxicações mais graves geralmente produzem hipertermia, midríase, sudorese, taquicardia, rigidez muscular, rabdomiólise, acidose metabólica, convulsões, hipercalemia, arritmias cardíacas, coagulopatia e morte.^{35,42} A diminuição da sensibilidade à dor pode fazer esses pacientes dançarem por horas com alguma lesão sem perceber, inclusive com a diminuição da percepção da temperatura corporal, o que apresenta risco em caso de uma lesão mais grave.⁴¹ O trismo e o bruxismo, que aparecem durante o uso, são aliviados pelos usuários com o uso de pirulitos ou chupetas.⁴¹

A presença de sintomas psiquiátricos pode ser aguda (até 24 horas após a ingestão), subaguda (de 24 horas até um mês após a ingestão) e crônica (após um mês de uso). As complicações agudas são ansiedade, insônia, *flashbacks*, ataques de pânico e psicoses, podendo, no caso de psicose paranoide, ter alguma reação de violência.^{39,40} As complicações subagudas incluem depressão, tonturas, ansiedade e irritabilidade. Complicações crônicas incluem transtorno de pânico, psicose, depressão, *flashbacks* e distúrbios da memória.^{39,40}

O problema mais grave relacionado à ingestão de MDMA é a hipertermia, que resulta em danos ao organismo, com rabdomiólise e insuficiência renal aguda, falência hepática, coagulopatia, convulsões e *delirium*.

Cerca de dois dias após a ingestão da substância, os usuários podem experimentar sintomas associados à relativa diminuição da serotonina, condição chamada *tuesday blues*,⁴¹ que consiste em sintomas tipicamente depressivos, com irritabilidade, anedonia e isolamento social. O uso frequente de MDMA está associado a déficits cognitivos, com dano permanente da memória.³⁵

Não há um antídoto específico para esse tipo de substância; portanto, o tratamento sintomático e de suporte deve ser considerado.³⁷ A redução da temperatura corporal é um dos primeiros procedimentos recomendados, pois as temperaturas elevadas têm sido implicadas em vários relatos de óbitos desencadeados pelo MDMA. O manejo da hipertermia inclui hidratação rápida, com cuidado para evitar intoxicação hídrica, e resfriamento corporal por meio de banho.^{40,41} Outras intervenções a serem consideradas no tratamento da hipertermia incluem suporte de cuidados intensivos.

Agitação e convulsões devem ser tratadas com BDZs – a clorpromazina não é indicada, por diminuir o limiar convulsivo.⁴⁰ Outra medida recomendada é a administração de carvão ativado (até 6 horas após a ingestão da droga), para minimizar a absorção da droga e fazer o

esvaziamento do conteúdo gástrico. O encaminhamento a uma unidade de cuidados intensivos pode ser indicado para ventilação e monitoramento.³⁶

Haloperidol na dose de 5 mg, via oral ou intramuscular, pode ser utilizado nos casos de agitação psicomotora e psicoses induzidas, sendo a via intramuscular a mais rápida. Novos antipsicóticos, como olanzapina e risperidona, produzem menos efeitos colaterais e podem ser administrados por via oral, ou, em caso de extrema agitação, a olanzapina pode ser aplicada por via intramuscular.³⁷

A hipertensão é mais bem tratada por meio da sedação; entretanto, caso não seja eficaz, o uso de vasodilatadores, como o nitroprussiato ou a fentolamina, pode ser útil para reverter o quadro.³⁷ A síndrome de abstinência inclui sintomas depressivos e de letargia, não existindo, até o momento, medicamentos específicos para esse quadro, sendo o tratamento sintomático. O encaminhamento para tratamento psicossocial deve ser feito o mais rápido possível.³⁷

GHB

O GHB (gama-hidroxibutirato) é um sedativo do SNC disponível como um líquido claro, pó branco, comprimido ou cápsula e pode ser feito em residências com ingredientes e receitas obtidos pela internet.³⁶ Em geral, é ingerido em forma líquida e, com frequência, misturado com álcool, o que aumenta seus efeitos.^{35,36} No Brasil, há relatos do uso dessa substância associado a violência sexual (“boa noite, Cinderela”) em festas do circuito GLBT (*gays*, lésbicas, bissexuais e transexuais).⁴³⁻⁴⁶

Os usuários costumam utilizar a droga para experimentar sensações de euforia e desinibição e aumentar a libido. Prefere-se o GHB ao álcool, devido à ausência dos efeitos da ressaca.⁴⁴ Estão associados ao uso dessa substância sintomas de tontura, hipersalivação, hipotonia e amnésia.³⁵

O uso crônico de GHB pode produzir dependência, e a interrupção de seu uso pode causar síndrome de abstinência, que inclui ansiedade, insônia, tremor e, em casos mais graves, psicose resistente ao tratamento.³⁵ A *overdose* pode resultar em respiração de Cheyne-Stokes, convulsões, coma e morte. Bradicardia e hipotermia também são relatadas por cerca de um terço dos pacientes admitidos em hospitais pelo uso de GHB e parecem estar relacionadas ao nível de consciência.³⁵

No tratamento da síndrome de abstinência, que pode se assemelhar à síndrome de abstinência de álcool, BDZs podem ser administrados em casos de agitação psicomotora.

Quetamina

A quetamina é um derivado da fenciclidina, utilizada principalmente por veterinários para uso anestésico. No Brasil, é vendida em lojas de produtos agropecuários com apresentação de receita prescrita por veterinário, sob nomes comerciais de Dopalen®, Cetamin®, Anesket® e Vetanarcol®. As gírias para essa substância são K ou *special K*, vitamina K, ketalar e super k.^{41,45} A substância está disponível em forma líquida, que em geral é administrada por via oral ou intravenosa; em pó, que pode ser aspirado por via nasal ou fumado associado a maconha ou tabaco;^{38,41} ou em cápsulas. Seus efeitos duram de 3 a 4 horas.

Quando usada em doses baixas, é associada a sensações de relaxamento chamadas *k-land* (terra do K). Doses mais altas podem produzir estados oníricos, alucinações, distorções visuais e sensação de experiência de quase morte, chamada *k-hole* (buraco do K).³⁶ Seu uso tem sido associado a lesões não intencionais causadas por insensibilidade à dor.⁴¹ Além disso, tem sido associada a agressão sexual, devido aos seus efeitos dissociativos.^{36,38}

Pessoas que usam quetamina enquanto estão em tratamento com antibióticos (p. ex., ofloxacina), anticolinérgicos, antipsicóticos, bupropiona, cafeína ou GHB correm maior risco de ter convulsões.⁴¹ Além dos sintomas citados, os usuários podem apresentar taquicardia, hipertensão, hipotermia, confusão mental, amnésia anterógrada e depressão respiratória com apneia. *Flashbacks* ou distúrbios visuais também podem ser apresentados dias ou semanas após a ingestão. Alguns usuários crônicos se tornam dependentes e exibem graves sintomas com a interrupção do uso, necessitando de desintoxicação.³⁵

Os sintomas agudos, muitas vezes, se resolvem sem intervenção. Entretanto, muitos pacientes chegam à sala de emergência principalmente com taquicardia e agitação. O tratamento deve ser de suporte com cuidados gerais.³⁶ O clínico deve observar o risco de sedação e proteger as vias aéreas.^{41,42} A administração de BDzs pode ser útil no caso de agitação psicomotora; porém, há o risco de prolongamento da meia-vida da quetamina, devido à interação medicamentosa.^{45,46}

Metanfetamina

A metanfetamina é um estimulante do sistema nervoso central com estrutura similar à da anfetamina, mas muito mais potente. Causa grande liberação de dopamina, provocando sensação de bem-estar que dura poucos minutos.³⁵ Geralmente é utilizada por via intranasal, intravenosa, oral ou fumada (usada como uma pedra de *crack*).⁴¹

Os efeitos dessa droga são, também, aumento da excitação, diminuição da fadiga e diminuição do apetite. Já os efeitos físicos agudos incluem elevação da pressão arterial, do pulso, do ritmo da respiração e da temperatura corporal.

Problemas médicos associados a dosagens excessivas incluem hemorragia cerebral, convulsões, hipertermia, arritmias, coma e morte. Danos psiquiátricos associados a seu uso incluem insônia, psicose, paranoia, ideação suicida e déficits cognitivos.³⁸ Os sintomas de abstinência são caracterizados por sintomas depressivos. Paranoia e agressividade também podem ocorrer. Ideação suicida é um risco quando os sintomas depressivos são graves.³⁸

Em caso de *overdose*, haloperidol pode ser administrado para controlar a agitação, e diazepam, para controlar as convulsões. A abordagem desses pacientes deve ser sintomática, com suporte para manutenção das funções vitais.⁴¹

OPIÁCEOS

Entre os diversos alcaloides encontrados nas preparações de ópio, estão a morfina e a codeína, denominadas *opiáceos naturais*. Por meio de modificações nas moléculas naturais, obtêm-se opiáceos semissintéticos, como a heroína. Opiáceos totalmente desenvolvidos em laboratório, como a meperidina (Dolantina®), o propoxifeno, a metadona e o fentanil, são denominados *opiáceos sintéticos*, ou *opioides*. Há, ainda, os denominados opiáceos endógenos, endorfinas e encefalinas, que são sintetizados pelo próprio organismo.⁴⁷

A *overdose* por opiáceos é caracterizada por inconsciência, miose pronunciada, bradicardia acentuada, depressão respiratória e coma. É uma emergência médica e deve receber intervenção imediata.⁷

O paciente comatoso deve ser atendido de acordo com protocolos adequados. A ocorrência de miose e sinais de injeção intravenosa nos membros superiores é indicativa de coma induzido por opiáceos. Quando possível, o tipo de opioide, a quantidade utilizada e o padrão de uso do paciente devem ser obtidos com terceiros.

Usuários crônicos podem apresentar também problemas clínicos associados, capazes de gerar ou complicar quadros comatosos, como pneumonias, tuberculose, nefropatias, constipações, distúrbios metabólicos e do equilíbrio acidobásico. É importante observar se há uso concomitante de outros depressores centrais, como álcool e BDZs. Usuários de heroína injetável estão suscetíveis a infecções por HIV e doenças sexualmente transmissíveis, hepatites, endocardites, celulites, abscessos locais e cerebrais, sepse, trombozes arteriais e tromboflebites.⁴⁷

Casos graves de *overdose* requerem administração imediata de naloxona, um antagonista opioide capaz de reverter a analgesia e a sedação induzidas pelo quadro. O paciente deve receber 0,8 mg de naloxona, por via intravenosa. Os sinais de melhora, como midríase, agitação, melhora do nível de consciência, melhora do padrão respiratório, são esperados nos minutos subsequentes. Caso não haja resposta em 15 minutos, deve-se aumentar a naloxona para a dose de 1,6 mg, podendo repetir 3,2 mg se ainda não houver resposta, e esperar mais 15 minutos. A administração de naloxona pode, no entanto, desencadear síndrome de abstinência em usuários crônicos.^{14,47} Na falta de resposta à administração de múltiplas doses, outras causas de coma devem ser investigadas. Opiáceos mais potentes (p. ex., fentanil) ou de longa duração (p. ex., metadona) podem requerer doses maiores de naloxona, ou mesmo infusão contínua.

Síndrome de abstinência

A síndrome de abstinência de opiáceos inicia-se com sintomas antecipatórios da falta da droga (ansiedade, fissura, comportamento de busca pela substância) e evolui para um quadro de sudorese, bocejos e espirros, rinorreia, lacrimejamento, midríase, piloereção, dores abdominais, náusea, vômitos, taquicardia, ansiedade e inquietação.^{6,7} A duração também varia de acordo com a meia-vida do opiáceo, levando, em média, de 5 a 10 dias. Sintomas tardios, como hipotensão, bradicardia, insônia, inapetência e fissura, podem permanecer durante vários meses.¹⁶

A síndrome de abstinência é autolimitada e tem baixa letalidade na ausência de problemas clínicos de base associados. Medidas de suporte devem ser instituídas com o objetivo de proporcionar bem-estar ao paciente e prevenir complicações clínicas. Pode-se, então, optar pelo tratamento de substituição por metadona ou sintomático com clonidina e BDZs.

A **metadona** pode ser administrada em doses de 10 mg a cada 4 horas, até o desaparecimento dos sintomas. Em geral, a dose total é de cerca de 40 a 60 mg. A dose estabelecida deve ser dividida e administrada duas vezes no dia seguinte. Pacientes jovens e com pouco tempo de uso devem ser estimulados à abstinência total, e a metadona deve ser suspensa. Usuários gravemente dependentes devem ser mantidos em tratamento de manutenção de metadona por tempo mais prolongado ou indeterminado.^{14,47}

A **clonidina**, um agonista alfa-2-adrenérgico, é capaz de inibir a atividade noradrenérgica, causando alívio dos sintomas autonômicos. O paciente deve receber inicialmente 0,2 mg, por via oral, a cada 4 horas, no máximo 1,2 mg/dia. A dose estabelecida deve ser mantida por três dias e então descontinuada de forma gradual: 0,2 mg/dia até a suspensão. A associação com um **BDZ** melhora as dores musculares, a insônia, a inquietação e a fissura pelos efeitos euforizantes dos opiáceos, não atingidos pela ação isolada da clonidina.⁷

MACONHA

O cânhamo (*Cannabis sativa*) é uma planta psicoativa encontrada em vários lugares do mundo, inclusive no Brasil. Os brotos femininos da planta secretam uma resina espessa que contém mais de 60 canabinoides, sendo o delta-9-tetraidrocanabinol (Δ -9-THC) o mais potente.¹⁶ A forma mais comum em nosso meio é a maconha ou o “fumo”, uma combinação de brotos, folhas, caules e sementes do cânhamo, que é fumada em cigarros de fabricação caseira (“baseados”). A concentração de THC nos brotos é variável, entre 0,5 e 8%. Já o haxixe é a resina coletada de folhas e brotos, sendo, por isso, mais concentrado (30%). Atualmente, a engenharia genética e o cultivo hidropônico têm produzido maconhas híbridas (p. ex., *skunk*), com maiores teores de THC, entre 17 e 20%.⁴⁸

O consumo agudo de maconha causa euforia, sensação de relaxamento, ansiedade, hipotensão, taquicardia, descoordenação motora, hiperemia conjuntival, boca seca e apetite exacerbado (larica). Além desses sintomas, a ação do THC sobre o sistema canabinoide provoca alterações cognitivas, como afrouxamento das associações, confusão, alterações na memória de fixação, prejuízos da atenção, entre outras.^{48,49} É importante mencionar também que, nos últimos tempos, receptores e neurotransmissores canabinoides endógenos foram identificados.

A toxicidade aguda da maconha é extremamente baixa, e não há casos de morte por intoxicação confirmadas na literatura. No entanto, acidentes secundários aos prejuízos do desempenho psicomotor (ao volante, no manuseio de máquinas) podem acontecer. Sintomas de pânico, medo intenso e disforia, além de reações depressivas e quadros psicóticos agudos, também podem apresentar-se com o uso.¹⁵ Além disso, quadros psicóticos agudos têm sido descritos tanto em usuários crônicos como em principiantes.⁵⁰ Os usuários, em geral, apresentam predisposição pessoal ou familiar.^{49,50}

Os **BDZs** (p. ex., diazepam, 10 mg, por via oral, repetindo se necessário) podem ser úteis nos quadros ansiosos agudos. Os neurolépticos (p. ex., haloperidol, 5 mg, por via oral ou intramuscular, em caso de alterações psicomotoras importantes) estão indicados na presença de sintomas psicóticos.¹⁴

LSD

A dietilamida do ácido lisérgico (LSD) é uma das substâncias psicoativas mais potentes: doses de 20 a 50 milionésimos de grama produzem efeitos com 4 a 12 horas de duração. É utilizada preferencialmente por via oral ou sublingual, na forma de micropontos, em tabletes ou mata-borrões. A LSD tem estrutura semelhante à da serotonina, seu provável elo alucinógeno. A tolerância para os efeitos do alucinógeno é rápida e reversível. Isso talvez justifique o uso esporádico e não aditivo da substância.^{16,51}

As complicações mais comuns do consumo de LSD são de natureza psiquiátrica: quadros ansiosos com sintomas de pânico (viagens de horror, ou *bad trips*) e/ou quadros psicóticos.⁵¹ Em geral, abordagens voltadas para a realidade, em ambientes calmos e com poucos estímulos sensoriais, costumam ser suficientes para a melhora de casos leves. Sintomas de maior intensidade, no entanto, podem ser controlados com BDZs (p. ex., diazepam, 10 mg, por via oral, repetindo, se necessário, ou midazolam, 15 mg, por via intramuscular, na presença de agitação) ou neurolépticos. Nos quadros de agitação e psicose, dá-se preferência a haloperidol, 5 mg, por via intramuscular. Comportamentos violentos e heteroagressivos podem requerer contenção mecânica, a fim de assegurar a integridade física do paciente e de terceiros.⁵²

SOLVENTES OU INALANTES

Com exceção do éter e do clorofórmio, já utilizados como anestésicos gerais, os solventes não apresentam nenhuma finalidade clínica. Eles são compostos de hidrocarbonetos alifáticos e aromáticos, facilmente voláteis, presentes em uma série de produtos, como aerossóis, vernizes, tintas, propelentes, colas, esmaltes e removedores. Alguns inalantes, importados de maneira clandestina, como o cloreto de etila, conhecido como “lança-perfume”, são utilizados sobretudo no carnaval ou em *raves*.

Recentemente, os *poppers* também têm ganhado espaço (nitratos vendidos pela internet ou ilicitamente em *sex shops*). Essa substância é popular entre o grupo *gay* devido a sua capacidade de aumentar o desejo e o desempenho sexual, provocando relaxamento muscular e facilitando as relações sexuais, principalmente anais.⁴³ Por ser via pulmonar, o início dos efeitos geralmente é bastante rápido, em questão de segundos ou minutos, e em cerca de 15 a 40 minutos já desapareceram. O usuário, então, acaba repetindo as aspirações várias vezes, com o objetivo de que os efeitos durem mais tempo.¹⁵

O mecanismo de ação dessas substâncias é muito complexo e ainda não está totalmente esclarecido.¹⁵ Sabe-se, no entanto, que os principais efeitos dos inalantes são euforia, desinibição, associados a tinidos e zumbidos, ataxia, risos imotivados e fala pastosa. O prosseguimento do uso pode levar a depressão do SNC, podendo chegar a coma e morte. Atrofias corticais e cerebelares também são possíveis em usuários crônicos, produzindo empobrecimento cognitivo e ataxia.⁵³

É importante que o consumo de inalantes seja sempre investigado diante de edemas supraglóticos e traqueobrônquicos em indivíduos que se apresentam nas salas de emergência com tosse, insuficiência respiratória e laringo ou broncoespasmo.⁵⁴

Os efeitos da intoxicação geralmente se resolvem em minutos a horas após a interrupção do uso do inalante. Efeitos tóxicos dependem do tipo de inalante utilizado e podem necessitar de tratamento emergencial se ocorrerem arritmias ou convulsões. Algumas substâncias, como o tolueno, podem provocar também lesão renal; portanto, tal função deve ser monitorada. O tratamento da intoxicação costuma ser de suporte.¹⁴

REFERÊNCIAS

1. Calle PA, Damen J, De Paepe P, Monsieurs KG, Buylaert WA. A survey on alcohol and illicit drug abuse among emergency department patients. *Acta Clin Belg.* 2006;61(4):188-95.
2. Reis AD, Figlie NB, Laranjeira R. Prevalence of substance use among trauma patients treated in a Brazilian emergency room. *Rev Bras Psiquiatr.* 2006;28(3):191-5.
3. Vroegop MP, Franssen EJ, van der Voort PH, van der Berg TN, Langewerg RJ, Kramers C. The emergency care of cocaine intoxications. *Neth J Med.* 2009;67(4):122-6.
4. Breton AR, Taira DA, Burns E, O'Leary J, Chung RS. Follow-up services after an emergency department visit for substance abuse. *Am J Manag Care.* 2007;13(9):497-505.
5. Brough R. Diagnostic dilemmas in substance disorders. *Aust Fam Physician.* 2010;39(8):536-7.
6. Jenkins DH. Substance abuse and withdrawal in the intensive care unit. *Surg Clin North Am.* 2000;80(3):1033-53.
7. Zealberg JJ, Brady KT. Substance abuse and emergency. *Psychiatr Clin North Am.* 1999;22(4):803-17.
8. Segatto ML, Pinsky I, Laranjeira R, Rezende FF, Vilela TR. Triagem e intervenção breve em pacientes alcoolizados atendidos na emergência: perspectivas e desafios. *Cad Saude Pública.* 2007;23(8):1753-62.
9. World Health Organization. Neuroscience of psychoactive substance use and dependence [Internet]. Geneva: WHO; 2004 [capturado em 05 fev. 2017]. Disponível em: http://www.who.int/substance_abuse/publications/en/Neuroscience_E.pdf.
10. Room R, Babor T, Rohm J. Alcohol and public health. *Lancet.* 2005;365(9458):519-30.
11. de Wit M, Jones DG, Sessler CN, Zilberberg MD, Weaver MF. Alcohol-use disorders in the critically ill patient. *Chest.* 2010;138(4):994-1003.
12. Diehl A, Laranjeira R. Tratamento farmacológico da síndrome de abstinência do álcool. In: Diehl A, Cordeiro DC, Laranjeira R. Tratamentos farmacológicos para dependência química: da evidência científica à prática clínica. Porto Alegre: Artmed; 2010. p. 94-101.
13. Laranjeira R, Nicastrí S, Jerônimo C, Marques AC, Gigliotti A, Campana A, et al. Consenso sobre a síndrome de abstinência do álcool (SAA) e o seu tratamento. *Rev Bras Psiquiatr.* 2000;22(2):62-71.
14. Leikin JB. Substance-related disorders in adults. *Dis Mon.* 2007;53(6):313-35.
15. Carlini E, Nappo SA, Galduróz JCF, Noto AR. Drogas psicotrópicas: o que são e como agem. *Rev IMESC.* 2001;3:9-35.
16. Ellenhorn MJ, Schonwald S, Ordog G, Wasserberger J, editors. Ellenhorn's medical toxicology: diagnosis and treatment of human poisoning. 2nd ed. Baltimore: Williams & Wilkins; 1997.
17. Alamo C, López-Muñoz B, Martín EC. Farmacología del etanol. In: Rubio G, Santo-Domingo J, editores. Guía práctica de intervención en el alcoholismo. Madrid: Agencia

Antidroga de la Comunidad de Madrid; 2000. p. 85-113.

18. White AM. What happened? Alcohol, memory blackouts, and the brain. *Alcohol Res Health*. 2003;27(2):186-96.
19. Marques ACPR, Ribeiro M. Álcool: abuso e dependência. In: Laranjeira R, Oliveira RA, Nobre MRC, Marques BW, editores. *Usuários de substâncias psicoativas: abordagem, diagnóstico e tratamento*. 2. ed. São Paulo: CREMESP; 2003. p. 29-47.
20. Lizasoain I, Moro MA, Lorenzo PA. Cocaína: aspectos farmacológicos. *Adicciones*. 2002;14(1):57-64.
21. Morton WA. Cocaine and psychiatric symptoms. *Prim Care Companion J Clin Psychiatry*. 1999;1(4):109-13.
22. Ribeiro M, Laranjeira R, Dunn J. Cocaína: bases biológicas da administração, abstinência e tratamento. *J Bras Psiquiatr*. 1998;47(10):497-511.
23. Harris DS, Everhart ET, Mendelson J, Jones RT. The pharmacology of coca ethylene in humans following cocaine and ethanol administration. *Drug Alcohol Depend*. 2003;72(2):169-82.
24. Donato EM, Rezende EP, Ribeiro M, Silva CJ. Farmacologia e neurobiologia do consumo de crack. In: Ribeiro M, Laranjeira R, editores. *O tratamento do usuário de crack*. São Paulo: Casa Leitura Médica; 2010. p. 49-59.
25. Sanchez ZVDM, Nappo SA. Sequência de drogas consumidas por usuários de crack e fatores interferentes. *Rev Saude Pública*. 2002;36(4):420-30.
26. Jones RT. Pharmacokinetics of cocaine: considerations when assessing cocaine use by urinalysis. *NIDA Res Monogr*. 1997;175:221-34.
27. Hatsukami DK, Fischman MW. Crack cocaine and cocaine hydrochloride are the differences myth or reality? *JAMA*. 1996;276(19):1580-8.
28. Carvalho VM. Pesquisa dos indicadores do uso de crack em amostras de urina de indivíduos submetidos a exame medicolegal [dissertação]. São Paulo: Universidade de São Paulo; 2006. p. 8-9.
29. Ribeiro M, Duailibi LB, Perrenoud LO. Perfil do usuário e história natural do consumo. In: Ribeiro M, Laranjeira R, editores. *O tratamento do usuário de crack*. São Paulo: Casa Leitura Médica; 2010. p. 60-73.
30. Koller K, Luiz T SC, Vianna Filho PTG, Granato JP, Silva CJ, Ribeiro M. Complicações clínicas do uso de crack. In: Ribeiro M, Laranjeira R, editores. *O tratamento do usuário de crack*. São Paulo: Casa Leitura Médica; 2010. p. 74-98.
31. Mesquita F, Kral A, Reingold A, Haddad I, Sanches M, Turienzo G, et al. Overdoses among cocaine users in Brazil. *Addiction*. 2001;96(12):1809-13.
32. Karch SB, Stephens B, Ho CH. Relating cocaine blood concentrations to toxicity: an autopsy study of 99 cases. *J Forensic Sci*. 1998;43(1):41-5.
33. Maraj S, Figueredo VM, Lynn Morris D. Cocaine and the heart. *Clin Cardiol*. 2010;33(5):264-9.

34. Ribeiro M, Laranjeira R, Cividanes GC. Transtorno bipolar do humor e uso indevido de substâncias psicoativas. *Rev Psiquiatr Clin.* 2005;32(supl1):78-88.
35. Gahlinger PM. Club drugs: MDMA, gamma-hidroxybutyrate (GHB), rohypnol, and ketamine. *Am Fam Physician.* 2004;69(11):2621-26.
36. Britt GC, McCance-Katz E. A brief overview of the clinical pharmacology of “club drugs”. *Subst Use Misuse.* 2005;40(9-10):1189-201.
37. Lemos T, Fonseca VSF. Anfetaminas e metanfetaminas. In: Diehl A, Cordeiro DC, Laranjeira R. *Tratamentos farmacológicos para dependência química: da evidência científica à prática clínica.* Porto Alegre: Artmed; 2010. p. 200-7.
38. Freese TE, Miotto K, Reback CJ. The effects and consequences of selected club drugs. *J Subst Abuse Treat.* 2002;23(2):151-6.
39. Laranjeira R, Dunn J, Rassi R, Fernandes M. “Êxtase” (3,4 metilenodioximetanfetamina, MDMA): uma droga velha e um problema novo? *Rev ABP-APAL.* 1996;18(3):77-81.
40. Ferigolo M, Machado AG, Oliveira NB, Barros HM. Ecstasy intoxication: the toxicological basis for treatment. *Rev Hosp Clin Fac Med Sao Paulo.* 2003;58(6):332-41.
41. Rome ES. It’s a rave new world: rave culture and illicit drug use in the young. *Cleve Clin J Med.* 2001;68(6):541-50.
42. Mills EM, Rusyniak DE. The role of the sympathetic nervous system and uncoupling proteins in the thermogenesis induced by 3,4-methylenedioxymethamphetamine. *J Mol Med.* 2004;82:787-99.
43. Cordeiro DC, Diehl A. Inalantes e outras drogas de abuso. In: Diehl A, Cordeiro DC, Laranjeira R. *Tratamentos farmacológicos para dependência química: da evidência científica à prática clínica.* Porto Alegre: Artmed; 2010. p. 230-9.
44. Mason PE, Kerns WP. Gamma hydroxybutyric acid (GHB) intoxication. *Acad Emerg Med.* 2002;9(7):7330-39.
45. Diehl A. Abuso e dependência de drogas anestésicas. In: Diehl A, Cordeiro DC, Laranjeira R. *Tratamentos farmacológicos para dependência química: da evidência científica à prática clínica.* Porto Alegre: Artmed; 2010. p. 297-304.
46. Tarabar AF, Nelson LS. The gamma-hydroxybutyrate withdrawal syndrome. *Toxicol Rev.* 2004;23(1):45-9.
47. Baltieri DA, Laranjeira R, Alves HNP, Araújo MR, Bernardo WM, Castro LAGP, et al. Projeto diretrizes: abuso e dependência de opiáceos [Internet]. São Paulo: AMB/CFM; 2008 [capturado em 05 fev.2017]. Disponível em: http://www.projetodiretrizes.org.br/projeto_diretrizes/008.pdf.
48. Solowij N. Cannabis and cognitive functioning. Cambridge: Cambridge University; 1998.
49. Hall WD. Cannabis use and the mental health of young people. *Aust N Z J Psychiatry.* 2006; 40(2):105-13.
50. Large M, Swapnil S, Compton MT, Slade T, Nielsen O. Cannabis use and earlier onset of psychosis. *Arch Gen Psychiatry.* 2011;68(6):555-61.
51. Nichols DE. Hallucinogens. *Pharmacol Ther.* 2004;101(2):131-81.

52. Perry P. LSD psychosis. California: Touro University; 1996.
53. Ribeiro M, Marques ACPR. Solventes. In: Laranjeira R, Oliveira RA, Nobre MRC, Marques BW, editores. Usuários de substâncias psicoativas: abordagem, diagnóstico e tratamento. 2. ed. São Paulo: CREMESP; 2003.
54. Kaloudová Y, Brychta P, Ríhová H, Suchánek I, Hrubá J, Seidlová D, et al. Inhalationinjury. Acta Chir Plast. 2000;42(4):115-7.



21

Gravidez e puerpério

Neury José Botega
João Luiz Pinto e Silva
Marcelo Luís Nomura

Transtornos e sintomas psiquiátricos são frequentes, especialmente, no primeiro e no terceiro trimestres de gestação e nos primeiros 30 dias de puerpério. Os fatores envolvidos na alta prevalência dizem respeito às diversas dimensões da gravidez e da maternidade. Além de alterações hormonais, que provocam transformações no comportamento e no psiquismo, gravidez e maternidade implicam várias mudanças na inserção social e na organização familiar, na autoimagem e na identidade da mulher. Este capítulo aborda os transtornos mentais que mais frequentemente incidem nesses períodos e fornece as orientações básicas sobre o uso de psicofármacos durante a gestação e a amamentação. Informações mais específicas sobre o assunto encontram-se no Capítulo 24.

TRANSTORNOS PSIQUIÁTRICOS NA GRAVIDEZ

O estudo da prevalência de transtornos psiquiátricos durante a gravidez, particularmente as alterações de humor, é comprometido pelo fato de que algumas características do período gestacional se sobrepõem e se confundem com sintomas depressivos da doença psiquiátrica. Esse é o caso da fadiga, do cansaço, das alterações do sono e do apetite, de peso e da libido, que são comuns durante a gravidez. Ademais, certas alterações metabólicas, como diabetes gestacional, anemia e disfunção tireoidiana, podem ser responsáveis por sintomas psiquiátricos.^{1,2}

Transtornos de ansiedade

O aparecimento de quadros de ansiedade patológica durante a gestação, como o transtorno de pânico, associa-se a aborto espontâneo, descolamento de placenta, partos prematuros espontâneos, baixo peso ao nascimento, partos vaginais instrumentais, baixo Apgar nos recém-nascidos e problemas de adaptação neonatal. Além disso, a frequente coexistência de ansiedade e depressão potencializa os efeitos deletérios de ambos no ciclo grávido-puerperal.^{3,4}

Há registros de piora na sintomatologia do transtorno obsessivo-compulsivo (TOC). Sabe-se, ainda, que uma porcentagem significativa de pacientes com TOC apresenta início ou piora da sintomatologia durante a gestação.⁵

Afora transtornos psiquiátricos diagnosticados segundo o DSM, a instabilidade de humor e o surgimento de ansiedade são comuns no início da gravidez, e quase todas as mulheres admitem preocupações relativas ao desenvolvimento do bebê, notadamente quando já houve casos de aborto, malformações ou natimorto. Essa ansiedade pode se exacerbar com os exames realizados durante o pré-natal.

Transtornos depressivos

Até 70% das pacientes têm sintomas depressivos durante a gravidez, sendo que de 10 a 16% preenchem critérios para o diagnóstico de depressão.⁶

Para vários autores, conflito conjugal, história familiar de depressão, antecedente de transtornos depressivos anteriores e gravidez indesejada constituem fatores de risco para o surgimento de quadros depressivos na gravidez. Transtornos depressivos são particularmente frequentes em mulheres com história de inúmeros abortos, bem como nos casos em que ocorre um aborto espontâneo. Uma revisão sistemática de 57 estudos, compreendendo inicialmente 1.361 casos selecionados, encontrou fortes evidências de acontecimentos estressantes, falta de apoio social e violência doméstica como fatores de risco para depressão.⁷

É importante destacar a ocorrência de reações de luto, normais ou “patológicas” (quando os sintomas são graves e prolongados), nos casos de óbito fetal, natimorto ou de malformações congênitas. Nessas situações, pode haver um pacto de silêncio entre equipe assistencial, familiares e a paciente que deu à luz. A criança que nasce morta acaba sendo representada como

uma “não pessoa”, sem nome, sem identidade e sem lembranças que possam facilitar o processo de luto. A alta precoce diminui o contato com outras mães, mas pode colocar a mulher em situação de isolamento em casa. Podem surgir pensamentos irracionais de vergonha e de culpa com base no que ela julga ter feito ou deixado de fazer durante a gestação, desajustes com parceiros e outros filhos, ansiedade, sintomas como fadiga e dor crônica, entre outras importantes consequências.^{8,9}

A gravidez que ocorre na adolescência é outra situação que requer mais atenção em saúde mental. Um estudo de caso-controle por nós realizado¹⁰ avaliou uma amostra de 110 adolescentes grávidas e 110 que nunca haviam engravidado. As frequências de casos de depressão, ansiedade e de história de tentativas de suicídio ao longo da vida foram, respectivamente: 26,3 vs. 13,6%; 43,6 vs. 28%; e 20 vs. 6,3%. Várias características psicossociais associaram-se à gravidez na adolescência, entre as quais: mudança de residência nos últimos três anos (*odds ratio* [OR] = 6); repetência (OR = 2,4) e abandono (OR = 5,2) escolares; morte de um dos pais na infância (OR = 2,9); tentativa de suicídio prévia (OR = 3,6); já ter sofrido abuso físico ou sexual (OR = 3,5); pouco apoio social (OR = 4,2); e uso semanal de bebida alcoólica (OR = 4,2).

Outros transtornos

A gravidez pode exacerbar quadros psicóticos preexistentes e, conseqüentemente, desencadear maior frequência de complicações obstétricas.¹¹ Na negação da gravidez, apenas uma minoria é de psicóticos (3, em 65 casos registrados por Wessel e colaboradores),¹² havendo, nesses casos, a forte influência de fatores psicodinâmicos. Na pseudociese, a mulher tem amenorreia, abdome distendido e mesmo alguns sinais de gravidez. Trata-se de um grupo heterogêneo, e apenas raramente pode-se caracterizar um quadro psicótico.¹³ A hiperprolactinemia ocasionada por certos antipsicóticos pode influenciar a crença de gravidez, a qual dificilmente se desfaz com exames laboratoriais e de imagem negativos para gravidez.

Tabaco, álcool, maconha, solventes (substâncias lipofílicas) e cocaína (hidrofílica) têm alto potencial de transferência placentária e, conseqüentemente, efeitos lesivos ao feto. A mais grave e bem documentada consequência do uso abusivo de álcool durante a gravidez é a síndrome alcoólica fetal, com mortalidade perinatal de 17%.¹⁴

No Brasil, a prevalência de achados compatíveis com o espectro da síndrome alcoólica fetal foi de 17% em uma avaliação de 94 crianças de um orfanato, e, nesse mesmo estudo, 50% das mães relatavam abuso de álcool durante a gestação.¹⁵

Em outro estudo nacional realizado com adolescentes grávidas, o exame do fio de cabelo revelou que 4,3% haviam usado maconha, e 2%, cocaína, no terceiro trimestre da gestação.¹⁶ Em nosso serviço, grávidas usuárias de substâncias psicoativas têm mais internações por ameaça de parto prematuro, e seus bebês são, mais frequentemente, pequenos para a idade gestacional.¹⁷

TRATAMENTO

Nesta seção, discutem-se princípios gerais do tratamento farmacológico. Para informações detalhadas sobre o uso de psicofármacos durante a gravidez, veja seção específica do Capítulo 24.

Três situações que requerem a decisão de usar ou não tal medicação desafiam médicos e pacientes:

- Em relação a um transtorno mental que se inicia durante a gravidez, iniciar ou não o uso de um psicofármaco?
- A mulher já vinha tomando psicofármacos quando descobriu a gravidez. A descoberta dá-se próxima do momento em que o coração e o sistema nervoso central já passaram pelos momentos cruciais da embriogênese (12 semanas de gestação). O que fazer?
- A mulher que sofre de um transtorno mental grave que se encontra estável com o uso de um psicofármaco gostaria de engravidar. Interromper ou não a medicação?

Há importantes benefícios advindos do tratamento dos transtornos psiquiátricos que ocorrem na gravidez. Quadros depressivos não tratados aumentam o risco de a paciente se expor a automedicação, tabaco e álcool, risco de desnutrição e dificuldade de seguir orientações médicas no pré-natal. Aumentam, também, o risco de suicídio, a depressão pós-parto e as dificuldades de vínculo entre mãe e bebê.

A taxa de recorrência de algumas patologias após a interrupção da medicação no primeiro trimestre para se evitar o período de maior risco de exposição ao feto pode ser bastante significativa: 68% para depressão, 50% para esquizofrenia e 83% para transtorno bipolar (contra 33% para as que padecem de transtorno bipolar, mas não fazem essa interrupção preventiva).^{2,18,19}

A ideia que se tem atualmente é a de que mulheres com doenças mentais graves e que desejam engravidar não deveriam interromper a medicação. Em mulheres que sofrem de quadros mais leves, com baixo risco de recorrência, a medicação pode ser diminuída, ou mesmo mantida, até a chegada da gravidez.²⁰ A diminuição progressiva de doses diminui a chance de efeitos-rebote no momento da interrupção. A cessação abrupta aumenta o risco de recorrência (que atinge 50% no prazo de duas semanas).¹⁹

Teratogênese

Psicofármacos geralmente implicam pouco risco obstétrico. A maior preocupação envolve os riscos para o bebê, como teratogênese (no caso de uso dessas drogas no primeiro trimestre da gestação), retardo do crescimento e disfunções neurológicas (no segundo e terceiro trimestres), toxicidade e abstinência após o parto (no caso de uso durante o terceiro trimestre), além dos possíveis prejuízos ao longo do desenvolvimento da criança (“teratogênese comportamental”) (Fig. 21.1). De um lado, há os riscos potenciais do medicamento; de outro, há o risco de (por

receio ou desconhecimento) não tratar adequadamente uma gestante que necessita de um psicofármaco.²¹

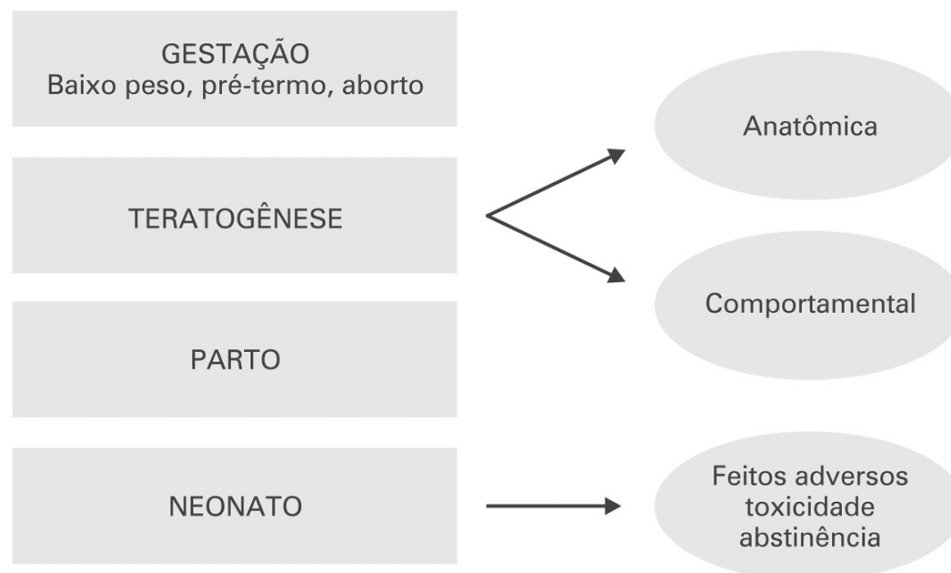


FIGURA 21.1 Riscos da exposição a psicofármacos durante a gestação.

As informações sobre teratogênese derivam de estudos não controlados, geralmente relatos de caso ou de série de casos (que servem como alerta), de estudos de coorte (seguimento ao longo do tempo) e de levantamentos feitos em bases de dados abrangentes que reúnem grande número de informações (da gestante, medicamentos utilizados, gestação, parto, condições da criança ao nascer e, às vezes, alguns anos após o nascimento). Essas informações precisam passar por tratamento estatístico adequado, a fim de controlar, *a posteriori*, uma série de fatores que frequentemente se associam a malformações (p. ex., idade e doenças maternas, polimedicação). Tais estudos podem tanto confirmar quanto rejeitar hipóteses levantadas a partir de casos esporádicos. Podem, também, gerar um número preocupante em um momento para, depois de alguns anos, gerar outro, menos preocupante que o primeiro, como ocorreu no caso da anomalia dos grandes vasos cardíacos acarretada pelo uso materno de lítio.²²

Além das preocupações com os efeitos dos psicofármacos sobre o feto e o neonato, o período gestacional implica aumento na metabolização de diversas drogas, no volume de líquido extracelular e na taxa de filtração glomerular, o que pode requerer ajuste na dose diária de certos medicamentos. Por exemplo, a maior taxa de filtração glomerular observada durante a gravidez diminui a litemia, havendo, então, necessidade de aumento da dose de lítio ingerida diariamente. No pós-parto, com o funcionamento corporal da mulher voltando aos níveis basais, novos ajustes (agora reduzindo doses) são necessários.

No processo de tomada de decisões, há o recurso de basear a escolha de um psicofármaco nas diretrizes de órgãos de regulação de medicamentos, ou em consensos de especialistas. Ademais, vários *sites* mantêm-se atualizados quanto ao risco teratogênico de diversos medicamentos e devem ser consultados (ver Quadro 24.7, no Cap. 24). Decisões envolvendo gestação e uso de psicofármacos não são simples. Embora tenha havido aumento na quantidade de informações,

não dispomos de respostas para oferecer as certezas que a gestante e os implicados na decisão gostariam de ter. O Quadro 21.1 contém princípios gerais que orientam o uso de psicofármacos durante a gravidez.

QUADRO 21.1

Princípios gerais na utilização de psicofármacos durante a gravidez

- Antes de prescrever para mulheres que possam engravidar, pergunte sobre métodos anticoncepcionais. Enfatize a necessidade de métodos anticonceptivos. Dê preferência a drogas potencialmente menos teratogênicas.
- Se a gravidez for descoberta após a nona semana, o período mais crítico para a teratogênese já passou.
- Se possível, evite medicamentos até a nona semana (isso é extensivo a drogas de origem herbária).
- A decisão de iniciar tratamento com psicofármaco deve ser compartilhada, ou seja, deve-se discutir com a paciente e seu parceiro os riscos e benefícios do uso (e do não uso). Comunicar-se, também, com o obstetra e o pediatra.
- Em muitos casos, o risco de recaída ou de recorrência (com consequente necessidade de altas doses de medicamento) será maior do que o risco para o feto.
- Usar a menor dose eficaz possível, dando preferência a drogas com boa documentação, evitando as mais recentemente lançadas.
- É preferível monoterapia à combinação de drogas.
- A farmacocinética muda durante a gravidez (atenção aos casos de tratamento com lítio).
- Se possível, reduzir doses logo antes do parto, a fim de diminuir efeitos tóxicos e de abstinência no neonato.
- Considere a eletroconvulsoterapia (ECT), especialmente em casos de catatonia, estupor depressivo e depressão com sintomas psicóticos.
- Procure informações atualizadas na internet.

A eletroconvulsoterapia (ECT) é segura para depressão grave, catatonia e transtornos afetivos na gravidez e no puerpério.²³ Pequenas modificações na técnica-padrão de aplicação da ECT são necessárias durante a gravidez.²⁴ Novos tratamentos biológicos (estimulação magnética transcraniana, estimulação vagal) ainda não foram adequadamente estudados durante a gravidez em termos de consequências obstétricas e de efeitos sobre o feto e o desenvolvimento da criança.

TRANSTORNOS PSIQUIÁTRICOS NO PUERPÉRIO

As doenças psiquiátricas do puerpério foram descritas na metade do século passado por Louis Victor Marcé, um médico francês. Os efeitos de septicemia, trauma, dor, perda de sangue e exaustão contribuíam para a elevada incidência dos quadros psicóticos no pós-parto.

A partir do século XX, a diminuição de infecções puerperais reduziu a incidência de quadros confusionais psicorgânicos. A variabilidade de sintomas psiquiátricos fez os transtornos psiquiátricos incidentes no puerpério passarem a ser diagnosticados dentro de outras rubricas. Nessa tendência, alinharam-se psiquiatras como Kraepelin e Bleuler, que não verificavam particularidades nos quadros puerperais.²⁵

Atualmente, o *Manual diagnóstico e estatístico de transtornos mentais* (DSM-5) e a *Classificação internacional de doenças e problemas relacionados à saúde* (CID-10) não consideram os quadros ocorridos nesse período como entidades específicas. O período puerperal é visto, no entanto, como um especificador. Não há, nessa classificação, a antiga categoria de psicose puerperal. Diversos autores, no entanto, chamam a atenção para a importância, quanto a possível especificidade, dos quadros confusionais que ocorrem no puerpério.

Transtornos do humor

Os transtornos do humor do puerpério dividem-se, classicamente, em quadros de depressão mais leve, chamados de disforia do pós-parto e depressão.

Disforia pós-parto (*puerperal blues*) é um fenômeno extremamente comum e considerado fisiológico por alguns autores. Até 85% das puérperas descrevem algum grau de tristeza ou humor depressivo nos primeiros dias do pós-parto. Essa incidência diminui a partir do décimo dia de puerpério. Normalmente, esses sintomas depressivos são leves, acompanhados de labilidade emocional, irritabilidade, tensão e sentimentos de inadequação. Não chegam a comprometer o funcionamento social ou a relação da mãe com o recém-nascido. A remissão espontânea dos sintomas sugere que não há necessidade de tratamento médico. A persistência do humor depressivo deve ser encarada como uma possível depressão maior, o que necessita de avaliação especializada e tratamento adequado.²⁶

Depressão puerperal é um quadro depressivo moderado ou grave, de início insidioso, normalmente durante a segunda ou terceira semana pós-parto. Incide em 10 a 15% das puérperas. Para 60% das mulheres acometidas, representa seu primeiro episódio de depressão. As mulheres que já tenham sofrido episódio anterior de depressão puerperal têm 50% de risco de padecer de novo episódio em gestações futuras. Até 30% das mulheres com história de depressão antes de engravidarem terão depressão puerperal.¹

A sintomatologia da depressão puerperal é semelhante à dos quadros depressivos que se dão em outros momentos do ciclo reprodutivo feminino. Inicia-se, geralmente, com sintomas de ansiedade, inquietude e insônia. Humor deprimido, anedonia e ansiedade são elementos centrais para o diagnóstico desse transtorno. No entanto, é característico que as mulheres que apresentam

quadros depressivos em período puerperal tenham, mais frequentemente, ideias delirantes, alucinações, humor lábil e desorientação espaço-temporal.²⁷

A exemplo do que ocorre na gravidez, a detecção da depressão maior no puerpério é dificultada pela sobreposição de sintomas depressivos a situações consideradas normais. Isso levou ao desenvolvimento de escalas próprias para estudos de transtornos do humor nesse período, sendo a de Edinburgh a mais utilizada e já validada no Brasil.^{28,29}

Transtornos psicóticos

Os transtornos psicóticos no puerpério encontram-se entre os quadros psiquiátricos mais graves, uma vez que representam risco tanto para a paciente quanto para o bebê. Esses transtornos afetam uma ou duas mulheres em cada mil que dão à luz, com incidência discretamente menor em estudos de base populacional, de 0,25 a 0,6 por mil nascimentos.³⁰ Durante os três primeiros meses que se seguem ao parto, há aumento de 10 a 20 vezes na incidência de crises psicóticas.³¹

Estudos epidemiológicos apontam uma taxa de internação psiquiátrica 18 vezes maior no primeiro mês de puerpério do que no período gestacional e 16 vezes maior no primeiro trimestre após o parto do que nos dois anos que o precederam.³¹ Entre as mulheres que já foram hospitalizadas devido a transtorno bipolar ou psicose previamente à gestação, 40% necessitam de nova internação no período puerperal.¹¹

O quadro clínico parece diferir dos transtornos psicóticos fora do período puerperal. O início costuma ser agudo, dentro das primeiras quatro semanas, principalmente entre o segundo e o décimo dia do puerpério. Raramente, os sintomas podem aparecer no último mês da gestação. Casos de início precoce, com instalação em até três semanas de puerpério, têm, predominantemente, sintomas afetivos relacionados a mania ou a hipomania (desinibição, hiperatividade motora, distratibilidade, euforia e disforia). Quadros mais tardios (até o sexto mês) são mais frequentemente esquizofreniformes (desconfiança, ideação paranoide, alucinações, discurso incoerente e desorganizado, mutismo, atos irracionais).¹¹

São frequentes, no puerpério, quadros psicóticos em que predominam confusão mental, com desorientação espaço-temporal e alterações da memória. Pode haver diminuição do nível de consciência e presença de um estado de perplexidade, com ar sonhador, chamado de confusão oniroide.²⁶

Cabe lembrar que a esquizofrenia está associada a diversas complicações perinatais, incluindo parto prematuro, aborto, baixos índices de Apgar ao nascer e restrição de crescimento fetal. As próprias crises psicóticas podem ocorrer mais frequentemente no puerpério.¹¹

Etiologia

Não há nenhum modelo teórico definitivo para explicar alterações de humor ou presença de sintomas psicóticos durante o período puerperal.³² Aspectos psicossociais e biológicos, assim como antecedentes de depressão prévia, apresentam-se entre os fatores relacionados aos transtornos puerperais.³³

A depressão puerperal tem uma clara relação com alguns fatores, como idade, pois tanto mulheres muito novas como mais velhas têm risco maior de desenvolver quadros depressivos. Mulheres cujos companheiros são menos colaborativos do ponto de vista prático e emocional correm mais risco de desenvolver quadros depressivos puerperais. Quadros depressivos anteriores, bem como sintomas depressivos na gravidez, relacionam-se fortemente ao risco de desenvolver transtornos depressivos no puerpério.²⁷

Após o parto, há um decréscimo abrupto dos níveis séricos de estradiol e estriol. Alguns estudos com animais demonstraram que o estradiol tem o papel de aumentar a síntese e diminuir a degradação de serotonina no sistema nervoso central (SNC). Teoricamente, a diminuição desse hormônio tornaria as pacientes mais propensas a apresentar quadros depressivos. No entanto, um estudo com 182 puérperas não demonstrou diferenças na concentração sérica desses hormônios entre mulheres deprimidas e não deprimidas.²⁷ Há algumas evidências de que alterações de humor estão associadas a transformações do nível de progesterona durante puerpério imediato, particularmente no *puerperal blues*. No entanto, o papel hormonal não é definitivo para explicar o fenômeno, nem os transtornos psicóticos e afetivos do puerpério.

A interação genético-ambiental entre fatores como as mudanças fisiológicas do puerpério em pacientes suscetíveis parece ser a etiologia mais provável em quadros de psicose desencadeados no puerpério.³⁰

Diagnóstico e tratamento

É importante a exclusão de patologias orgânicas que possam estar causando os sintomas. O surgimento de alterações de humor acompanhadas de convulsões ou alterações do nível de consciência no fim da gravidez exige o diagnóstico diferencial com eclampsia. Devido à maior prevalência durante o puerpério, devem ser investigadas tireoidopatias (tireotoxicose, hipotireoidismo) e síndrome de Sheehan. Os transtornos psiquiátricos psicóticos e depressivos podem ser secundários a tromboflebite cerebral e, após infecção pélvica, a encefalites, bem como à indução por drogas anti-hipertensivas.

É importante notar, ainda, que a apresentação clínica dos transtornos mentais do puerpério varia muito rapidamente. Isso indica a necessidade de acompanhamento próximo e flexibilidade no tratamento medicamentoso. Por exemplo, pacientes que apresentam quadros psicóticos podem desenvolver transtornos depressivos com melhora dos sintomas positivos (delírios, alucinações), necessitando de alterações no tratamento.

O tratamento dos transtornos puerperais é baseado na combinação de tratamento medicamentoso e psicoterapia. O uso de ECT é recomendado em casos de maior gravidade.³⁴ No caso de transtornos psicóticos, sabe-se ainda que pacientes que desenvolvem quadros esquizofreniformes no puerpério raramente irão evoluir para esquizofrenia. Dessa forma, o tratamento com antipsicóticos não deve ser prolongado como em um primeiro surto psicótico não puerperal. O mesmo raciocínio não se aplica a quadros maníacos, já que é frequente que pacientes com transtorno bipolar desenvolvam um primeiro quadro maníaco no puerpério. Uma

próxima gravidez (e próximo puerpério) deve ser acompanhada por um psiquiatra, e deve-se considerar a administração preventiva de um psicofármaco.

Transtornos mentais no pós-parto interferem não apenas na segurança da paciente como também na de seu bebê. As mães devem ser observadas em sua relação com seus recém-nascidos – ideias que expressam e como reagem ao contato e às demandas da criança. Mães deprimidas podem acreditar que o recém-nascido sofre de doenças ou malformações, podem sentir-se culpadas por não sentirem amor pelo bebê, por não estarem cuidando dele. Uma mãe psicótica pode encontrar-se sob influência delirante, negar o nascimento de um filho ou mesmo ver na criança algo anormal, ameaçador. Deve-se, nesse caso, estar atento para o risco de filicídio e de suicídio.

A crise da paciente contaminará a família, aturdida e angustiada com um quadro psiquiátrico surgido abruptamente, em um momento em que todos contavam com um ambiente diferente e especial, onde deveria predominar a alegria. Os familiares farão muitas perguntas. Psiquiatra, obstetra e pediatra serão chamados a dialogar, tranquilizando essas pessoas que necessitarão de orientação e de apoio. A abordagem psicológica, centrada nos princípios da psicoterapia de crise, será fundamental.

Em casos mais graves, a internação, ainda que dramática nessa circunstância, pode ser necessária. Nesse caso, deve-se avaliar a possibilidade de propiciar encontros frequentes entre a mãe e o bebê. Esse contato, que deve ser sempre supervisionado, é fundamental para a paciente ir se adequando à realidade e vinculando-se ao bebê.

ALEITAMENTO

A concentração de psicofármacos no leite materno geralmente é baixa, mas muito variável ao longo do tempo, em uma mesma mulher. De modo geral, enquanto a concentração plasmática de um antidepressivo no sangue fetal chega a ser 50% do nível sanguíneo materno, menos de 1% deste último é detectado no leite materno. O lítio é uma exceção, pois sua concentração no sangue do lactente é, em média, 25% da litemia materna, podendo chegar a 70%.³⁵

Em geral, parece ser seguro utilizar antidepressivos inibidores seletivos da recaptação de serotonina (ISRSs) e antipsicóticos típicos em bebês saudáveis nascidos a termo. Há pouca informação quanto a antidepressivos lançados mais recentemente e antipsicóticos atípicos. Entre estes, a olanzapina tem mais evidência de ser segura. Alguns psicotrópicos já foram associados a risco em estudos de seguimento e podem implicar risco considerável, devendo ser evitados (ziprasidona, levomepromazina, agomelatina, lítio, vareniclina e dissulfiram).^{2,36}

A possibilidade de toxicidade no bebê depende não somente da quantidade de medicação ingerida pela mãe como também da taxa de metabolização do lactente. Durante as primeiras semanas de vida, essa taxa é de 33,33 a 50% da que é observada em adultos. Ela vai, no entanto, aumentando, até que, por volta dos 2 a 3 meses de idade, ultrapassa a do adulto. Em crianças prematuras, ou em casos em que haja sinais de comprometimento hepático, a mãe não deve usar psicofármacos.

Sempre que se decidir medicar a paciente com um psicofármaco, o lactente deverá ser observado atentamente quanto a sedação, temperatura, respiração, tônus muscular, tremores, vigor e duração da mamada e evolução do peso. A recomendação de interrupção da amamentação deve ser avaliada com muito cuidado, considerando sempre os custos e benefícios dessa conduta.

O Quadro 21.2 apresenta algumas orientações em relação ao uso de psicofármacos em mulheres que estão amamentando. O Capítulo 24 contém uma seção que discute mais especificamente quais psicofármacos são mais adequados em mães que estão amamentando, além de sugerir *sites* para atualização.

QUADRO 21.2

Princípios gerais no aleitamento

- A concentração de psicofármacos no leite deve ser, em geral, baixa. No entanto, há poucos estudos sobre efeitos no lactente e no desenvolvimento da criança. Recomenda-se cautela.
- Evitar exposição a psicofármacos em caso de lactentes prematuros ou que apresentem problemas hepáticos, renais, cardíacos ou neurológicos.
- Evitar drogas conhecidas por causar sedação e ter meia-vida plasmática longa, efeitos adversos e toxicidade.
- O medicamento que já vinha sendo usado durante a gravidez pode ser mantido, pois sua concentração no leite é menor. Deve-se manter a menor dose eficaz possível.
- Dar preferência a tomadas em dose única, logo antes da mamada que antecede o período mais longo de sono do bebê. Isso fará o pico da concentração da droga no leite incidir fora do período da mamada.
- Evitar polimedicação e desaconselhar medicamentos sem receita médica.
- A exemplo do que ocorre em relação ao uso de psicofármacos durante a gestação, deve-se discutir prós e contras com os responsáveis e manter a comunicação com o pediatra.

PROGNÓSTICO

Estima-se entre 15 e 50% a recorrência de transtornos depressivos em períodos puerperais subsequentes.³⁷⁻³⁹ O risco de a paciente desenvolver novo quadro psicótico, mesmo fora de períodos puerperais, é de aproximadamente 60%.⁴⁰ Portanto, considerando os resultados desses estudos, alguns profissionais recomendam, para certos subgrupos de grávidas, o tratamento profilático de transtornos psiquiátricos puerperais. Entre as opções, encontra-se a utilização do carbonato de lítio em mulheres acometidas pelo transtorno bipolar, a partir da 36ª semana de gestação ou logo após o parto (nesse caso, não será recomendável amamentar). Para mulheres com história de depressão puerperal, pode-se pensar em um antidepressivo ao fim da gestação ou logo após o parto.

Embora muitos clínicos decidam medicar uma paciente em tais condições, uma revisão sistemática não conseguiu reunir evidências para afirmarmos que o uso de um antidepressivo, ao fim da gravidez, resulte em redução de depressão puerperal.⁴¹

Considerando a elevada prevalência e as graves consequências da depressão puerperal, têm sido estimulados, mais recentemente, esforços para rastreamento e prevenção. Ensaios clínicos iniciais mostram que protocolos específicos com esse objetivo reduzem significativamente ansiedade e depressão maternas.⁴²

REFERÊNCIAS

1. Llewellyn AM, Stowe ZN, Nemeroff CB. Depression during pregnancy and puerperium. *J Clin Psychiatry*. 1997;58(Suppl 15):26-32.
2. Chisolm MS, Payne JL. Management of psychotropic drugs during pregnancy. *BMJ*. 2016;532:h5918.
3. O'Connor TG, Heron J, Glover V; Alspac Study Team. Antenatal anxiety predicts child behavioral/emotional problems independently of postnatal depression. *J Am Acad Child Adolesc Psychiatry*. 2002;41(12):1470-7.
4. Staneva A, Bogossian F, Pritchard M, Wittkowski A. The effects of maternal depression, anxiety, and perceived stress during pregnancy on preterm birth: a systematic review. *Women Birth*. 2015;28(3):179-93.
5. Forray A, Focseneanu M, Pittman B, McDougle CJ, Epperson CN. Onset and exacerbation of obsessive-compulsive disorder in pregnancy and the postpartum period. *J Clin Psychiatry*. 2010;71(8):1061-8.
6. Klein MH, Essex MJ. Pregnant or depressed? The effect of overlap between symptoms of depression and somatic complaints of pregnancy on rates of major depression in the second trimester. *Depression*. 1995;2(6):308-14.
7. Lancaster CA, Gold KJ, Flynn HA, Yoo H, Marcus SM, Davis MM. Risk factors for depressive symptoms during pregnancy: a systematic review. *Am J Obstet Gynecol*. 2010;202(1):5-14.
8. Bourne S, Lewis E. Pregnancy after stillbirth or neonatal death: psychological risks and management. *Lancet*. 1984;2(8393):31-3.
9. Burden C, Bradley S, Storey C, Ellis A, Heazell AE, Downe S, et al. From grief, guilt pain and stigma to hope and pride: a systematic review and meta-analysis of mixed-method research of the psychosocial impact of stillbirth. *BMC Pregnancy Childbirth*. 2016;16:9.
10. Freitas GV, Cais CF, Stefanello S, Botega NJ. Psychosocial conditions and suicidal behavior in pregnant teenagers: a case-control study in Brazil. *Eur Child Adolesc Psychiatry*. 2008;17(6):336-42.
11. Harlow BL, Vitonis AF, Sparen P, Cnattingius S, Joffe H, Hultman CM. Incidence of hospitalization for postpartum psychotic and bipolar episodes in women with and without prior prepregnancy or prenatal psychiatric hospitalizations. *Arch Gen Psychiatry*. 2007;64(1):42-8.
12. Wessel J, Gauruder-Burmester A, Gerlinger C. Denial of pregnancy: characteristics of women at risk. *Acta Obstet Gynecol Scand*. 2007;86(5):542-6.
13. Rosch DS, Sajatovic M, Sivec H. Behavioral characteristics in delusional pregnancy: a matched control group study. *Int J Psychiatry Med*. 2002;32(3):295-303.
14. Greenfield SF, Sugarman DE. Treatment and consequences of alcohol abuse and dependence during pregnancy. In: Yonkers K, Little B, editors. *Management of psychiatric disorders during pregnancy*. London: Hodder Arnold; 2001. p. 213-27.

15. Strömmland K, Ventura LO, Mirzaei L, Oliveira KF, Bandim JM, Parente IA, et al. Fetal alcohol spectrum disorders among children in a Brazilian orphanage. *Birth Defects Res A Clin Mol Teratol.* 2015;103(3):178-85.
16. Bessa MA, Mitsuhiro SS, Chalem E, Barros MM, Guinsburg R, Laranjeira R. Underreporting of use of cocaine and marijuana during the third trimester of gestation among pregnant adolescents. *Addict Behav.* 2010;35(3):266-9.
17. Tamashiro EM. Detecção e seguimento de gestantes usuárias de drogas psicoativas [dissertação]. Campinas: Faculdade de Ciências Médicas, Universidade Estadual de Campinas; 2015.
18. Barnes TR; Schizophrenia Consensus Group of British Association for Psychopharmacology. Evidence-based guidelines for the pharmacological treatment of schizophrenia: recommendations from the British Association for Psychopharmacology. *J Psychopharmacol.* 2011;25(5):567-620.
19. Viguera A, Whitfield T, Baldessarini R, Newport DJ, Stowe Z, Reminick A, et al. Risk of recurrence in women with bipolar disorder during pregnancy: prospective study of mood stabilizer discontinuation. *Am J Psychiatry.* 2007;164(12):1817-24.
20. Altemus M, Occhiogrosso M. Obstetrics and gynecology. In: Ferrando SJ, Levenson JL, Owen JA, editors. *Clinical manual of psychopharmacology in the medically III.* Washington: APA; 2010. p. 339-70.
21. Wisner KL, Sit D, Hanusa B, Moses-Kolko EL, Bogen DL, Hunker DF, et al. Major depression and antidepressant treatment: impact on pregnancy and neonatal outcomes. *Am J Psychiatry.* 2009;166(5):557-66.
22. Menon SJ. Psychotropic medication during pregnancy and lactation. *Arch Gynecol Obstet.* 2008;277(1):1-13.
23. Pinette MG, Santarpio C, Wax JR, Blackstone J. Electroconvulsive therapy in pregnancy. *Obstet Gynecol.* 2007;110(2 Pt 2):465-6.
24. Anderson EL, Reti IM. ECT in pregnancy: a review of the literatures from 1941 to 2007. *Psychosom Med.* 2009;71(2):235-42.
25. Cucchiari G, Mariano EC, Botega NJ. Psicose puerperal: revisão e casos clínicos. *J Bras Ginecol.* 1993;103(9):347-52.
26. Brockington IF, Winokur G, Dean C. Puerperal psychosis. In: Kumar R, Brockington IF, editors. *Motherhood and mental illness.* London: Wright; 1988.
27. O'Hara MW. Postpartum depression: what we know. *J Clin Psychol.* 2009;65(12):1258-69.
28. Cox JL, Holden JM, Sagovsky R. Detection of postnatal depression. Development of the 10-item Edinburgh Postnatal Depression Scale. *Br J Psychiatry.* 1987;150:782-6.
29. Santos MF, Martins FC, Pasquale L. Escala de autorregistro de depressão pós-parto: estudo no Brasil. In: Goreinstein C, Andrade LHSG, Zuardi AW, editores. *Escala de avaliação clínica em psiquiatria e psicofarmacologia.* São Paulo: Lemos; 2000. p. 97-101.
30. Bergink V, Rasgon N, Wisner KL. Postpartum psychosis: madness, mania, and melancholia in motherhood. *Am J Psychiatry.* 2016;173(12):1179-88.

31. Kendell RE, Chalmers JC, Platz C. Epidemiology of puerperal psychoses. *Br J Psychiatry*. 1987;150:662-73.
32. Pritchard DB, Harris B. Aspects of perinatal psychiatric illness. *Br J Psychiatry*. 1996;169(5):555-62.
33. Vasconcelos AJA, Melzer DL. Disforia do pós-parto. In: Vasconcelos AJA, Teng CT. *Psiquiatria perinatal*. São Paulo: Atheneu; 2010. p. 71-88.
34. Forray A, Ostroff RB. The use of electroconvulsive therapy in postpartum affective disorders. *J ECT*. 2007;23(3):188-93.
35. Owen JA. Psychopharmacology. In: Levenson JL, editor. *The American Psychiatric Publishing textbook of psychosomatic medicine: psychiatric care of the medically ill*. 2nd ed. Washington: APA; 2011. p. 957-1019.
36. Payne JL, Meltzer-Brody S. Antidepressant use during pregnancy: current controversies and treatment strategies. *Clin Obstet Gynecol*. 2009;52(3):469-82.
37. Protheroe C. Puerperal psychoses: a long term study 1927-1961. *Br J Psychiatry*. 1969;115(518):9-30.
38. Pfuhmann B, Franzek E, Beckmann H, Stöber G. Long-term course and outcome of severe postpartum psychiatric disorders. *Psychopathology*. 1999;32(4):192-202.
39. Wesseloo R, Kamperman AM, Munk-Olsen T, Pop VJ, Kushner SA. Risk of postpartum relapse in bipolar disorder and postpartum psychosis: a systematic review and meta-analysis. *Am J Psychiatry*. 2016;173(2):117-27.
40. Videbech P, Gouliaev G. First admission with puerperal psychosis: 7-14 years of follow-up. *Acta Psychiatr Scand*. 1995;91(3):167-73.
41. Howard LM, Hoffbrand S, Henshaw C, Boath L, Bradley E. Antidepressant prevention of postnatal depression. *Cochrane Database Syst Rev*. 2005;(2):CD004363.
42. Werner EA, Gustafsson HC, Lee S, Feng T, Jiang N, Desai P, et al. Postpartum depression prevention through the mother-infant dyad. *Arch Womens Ment Health*. 2016;19(2):229-42.



Transtornos alimentares no hospital geral

Celso Garcia Junior

Ana Luísa Marques Traballi

Danielle L. R. S. Argolo

Este capítulo aborda aspectos básicos dos transtornos alimentares (TAs) que mais comumente levam o paciente ao hospital geral e tem como intuito auxiliar o clínico na abordagem inicial de pacientes com anorexia nervosa e bulimia. Assim, são destacados, além do quadro clínico e da classificação diagnóstica dos principais TAs, o diagnóstico diferencial com outros transtornos mentais e doenças somáticas, as potenciais complicações clínicas, entre elas a gravíssima síndrome da realimentação e seu manejo, além da comorbidade entre bulimia e diabetes melito. São discutidos também aspectos psiquiátricos da cirurgia bariátrica.

Os transtornos alimentares (TAs) são transtornos psiquiátricos potencialmente graves, de etiologia multifatorial e que acometem, sobretudo, mulheres jovens e adolescentes. São caracterizados por perturbações persistentes no comportamento alimentar, com consequentes alterações do consumo ou da absorção de alimentos, que resultam em comprometimento significativo da saúde física ou do funcionamento psicossocial do indivíduo.¹

A quinta edição do *Manual diagnóstico e estatístico de transtornos mentais* (DSM-5), publicada em 2013,¹ pela American Psychiatric Association, classifica os TAs em oito entidades, que são relacionadas no Quadro 22.1. Entre elas, a anorexia nervosa (AN) e a bulimia nervosa (BN) são as que mais frequentemente levam a complicações clínicas relacionadas à desnutrição ou aos comportamentos purgativos. Por isso, pacientes que sofrem com AN ou BN são, com frequência, atendidos no hospital geral, seja em unidades de emergência, seja em enfermarias. A inclusão de algumas perguntas simples na anamnese permite a triagem adequada dos transtornos alimentares (Quadro 22.2).²

QUADRO 22.1

Classificação dos transtornos alimentares pelo DSM-5

- Pica
- Transtorno de ruminação
- Transtorno alimentar restritivo/evitativo
- Anorexia nervosa
- Bulimia nervosa
- Transtorno de compulsão alimentar
- Outro transtorno alimentar especificado
- Transtorno alimentar não especificado

Fonte: American Psychiatric Association.¹

QUADRO 22.2

Temas para perguntas recomendados na triagem inicial dos transtornos alimentares

- Alterações do peso
- Prática de dietas alimentares restritivas
- Episódios de compulsão alimentar
- História de autoindução de vômitos e uso de laxantes ou diuréticos com a finalidade de emagrecer ou evitar ganho de peso
- Insatisfação com o próprio corpo
- Prática de atividades físicas
- Irregularidades do ciclo menstrual

Fonte: Com base em Power e colaboradores.²

EPIDEMIOLOGIA

Estudos sobre a prevalência dos TAs ao longo da vida, entre a população em geral, utilizando-se os critérios do DSM-IV-R,³ mostraram taxas que variam entre 0,3 e 2,2%, para AN, e 0,1 e 2,9%, para BN.⁴⁻⁷ Entretanto, com as mudanças introduzidas pelo DSM-5, essas taxas também mudaram. Smink e colaboradores⁸ afirmam que, usando os novos critérios, a prevalência de AN e BN entre as mulheres é em torno de 4 e 2%, respectivamente.⁸ Isso decorre do fato de que, na nova classificação, os critérios para AN e BN tornaram-se mais amplos, permitindo que um maior número de indivíduos possa ser considerado com um transtorno especificado, diminuindo, assim, o número de indivíduos diagnosticados com um quadro inespecífico.

ANOREXIA NERVOSA

Pacientes com AN apresentam diminuição persistente da ingesta alimentar com consequente perda de peso corporal, levando a níveis inferiores àqueles esperados para a idade e o gênero. Com frequência, tais indivíduos não reconhecem que estão doentes ou relatam, com sofrimento, que têm medo de se tratar e se tornarem obesos. Assim, a restrição alimentar é acompanhada por medo patológico de engordar e percepção distorcida da forma ou do tamanho do corpo, com o qual o paciente se sente insatisfeito. Com o intuito de perder peso, alguns pacientes praticam exercícios físicos exagerados, incompatíveis com a intensidade ou a frequência preconizadas saudáveis, ou, ainda, utilizam métodos purgativos, como a indução de vômitos ou o uso de substâncias laxativas. O Quadro 22.3 relaciona os critérios diagnósticos do DSM-5 para AN e BM.¹

QUADRO 22.3

Critérios diagnósticos do DSM-5 para anorexia nervosa e bulimia nervosa

Anorexia nervosa

- A. Restrição da ingesta calórica em relação às necessidades, levando a um peso corporal significativamente baixo no contexto de idade, gênero, trajetória do desenvolvimento e saúde física. Peso significativamente baixo é definido como um peso inferior ao peso mínimo normal ou, no caso de crianças e adolescentes, menor do que o minimamente esperado.
- B. Medo intenso de ganhar peso ou de engordar, ou comportamento persistente que interfere no ganho de peso, mesmo estando com peso significativamente baixo.
- C. Perturbação no modo como o próprio peso ou a forma corporal são vivenciados, influência indevida do peso ou da forma corporal na autoavaliação ou ausência persistente de reconhecimento da gravidade do baixo peso corporal atual.

Tipo restritivo: Durante os últimos três meses, o indivíduo não se envolveu em episódios recorrentes de compulsão alimentar ou comportamento purgativo (i.e., vômitos autoinduzidos ou uso indevido de laxantes, diuréticos ou enemas). Esse subtipo descreve apresentações nas quais a perda de peso seja conseguida essencialmente por meio de dieta, jejum e/ou exercício excessivo.

Tipo compulsão alimentar purgativa: Nos últimos três meses, o indivíduo se envolveu em episódios recorrentes de compulsão alimentar purgativa (i.e., vômitos autoinduzidos ou uso indevido de laxantes, diuréticos ou enemas).

Bulimia nervosa

- A. Episódios recorrentes de compulsão alimentar. Um episódio de compulsão alimentar é caracterizado por ambos os aspectos:
 - 1. Ingestão, em um período limitado de tempo (p. ex., dentro de cada período de 2 horas), de uma quantidade de alimentos definitivamente maior do que a maioria dos indivíduos consumiria no mesmo período sob circunstâncias semelhantes.
 - 2. Sensação de falta de controle sobre a ingestão durante o episódio (p. ex., um sentimento de não conseguir parar de comer ou controlar o quanto se está ingerindo).
- B. Comportamentos compensatórios inapropriados recorrentes, a fim de impedir o ganho de peso, como vômitos autoinduzidos, uso indevido de laxantes, diuréticos ou outros medicamentos, jejum ou exercício em excesso.
- C. A compulsão alimentar e os comportamentos compensatórios inapropriados ocorrem, em média, no mínimo uma vez por semana durante três meses.
- D. A autoavaliação é indevidamente influenciada pela forma e pelo peso corporais.
- E. A perturbação não ocorre exclusivamente durante episódios de anorexia nervosa.

Fonte: American Psychiatric Association.¹

Dependendo dos sintomas alimentares apresentados nos últimos três meses, a anorexia nervosa pode ser classificada em dois subtipos:

1. Tipo restritivo: quando o indivíduo não apresenta compulsões alimentares ou episódios de purgação e/ou uso de laxantes. A perda de peso se dá essencialmente pela restrição alimentar e/ou exercícios físicos intensos.

2. Tipo compulsão alimentar purgativa: quando estão presentes episódios de compulsão alimentar e uso de métodos purgativos, como vômitos autoinduzidos e uso indevido de laxantes, diuréticos ou enemas.

Em geral, os indivíduos com AN apresentam *insight* prejudicado e negam a existência desse transtorno, argumentando que se trata apenas da escolha por um estilo de vida ou da repugnância à ideia de ser obeso. Em geral, eles são levados por familiares a uma avaliação clínica devido às consequências da desnutrição. Essa avaliação clínica pode representar um momento especialmente importante para abordar o diagnóstico, evidenciar as consequências clínicas da anorexia nervosa, a morbidade física e mental associada e o risco de vida, estimulando o seguimento de um tratamento apropriado.

BULIMIA NERVOSA

Os pacientes com bulimia, em geral, apresentam peso dentro dos parâmetros de normalidade considerando gênero e idade ou, eventualmente, sobrepeso. Apresentam episódios de compulsão alimentar, com ingesta definitivamente muito maior do que se esperaria de uma pessoa nas mesmas circunstâncias e em intervalo de tempo semelhante, com a sensação marcante de perda de controle e culpa. A compulsão é seguida de comportamentos que têm como objetivo evitar o ganho de peso, como a autoindução de vômitos, o uso de laxantes ou de substâncias anorexígenas, a prática de jejuns ou de exercícios físicos extenuantes e exagerados. O medo mórbido de engordar, a distorção da percepção da forma ou do peso do próprio corpo e a autoavaliação centrada na forma e no peso do corpo, com o qual os pacientes mostram-se sempre insatisfeitos, são sintomas psicopatológicos que pacientes com AN e BN compartilham. O Quadro 22.3 relaciona os critérios diagnósticos do DSM-5 para BN.¹ Os alimentos ingeridos durante um episódio de compulsão podem ser diversificados, mas geralmente são alimentos evitados em outros momentos. Indivíduos com BN em geral sentem vergonha dos episódios de compulsão e tentam ocultá-los, comendo, muitas vezes, em segredo.

Fatores desencadeantes de uma compulsão alimentar, em geral, relacionam-se com afetos negativos, situações estressantes, restrições dietéticas ou insatisfação em relação à forma ou ao peso do corpo. O ato da compulsão minimiza esses sentimentos em curto prazo, mas a culpa e o fracasso surgem em seguida ao descontrole alimentar e desencadeiam os comportamentos compensatórios. Entre eles, os vômitos autoinduzidos são os mais frequentes e são descritos como algo que traz alívio do desconforto físico e do medo de engordar. Outros métodos utilizados são o uso de laxantes, diuréticos, enemas, exercícios físicos exagerados e incompatíveis com hábitos saudáveis, medicamentos com efeito anorexígeno e jejuns prolongados.

DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL

O diagnóstico dos transtornos alimentares é clínico e deve ser confirmado a partir da observação da presença de comportamentos e pensamentos patológicos listados entre os critérios diagnósticos do DSM-5.¹ Entretanto, indivíduos com AN podem negar comportamentos e pensamentos patológicos relacionados aos transtornos alimentares. Nesse caso, deve-se investigar os sintomas por meio de perguntas que explorem indiretamente o medo patológico de engordar e a preocupação obsessiva com o peso e a forma do corpo, obter informações objetivas com familiares ou acompanhantes, além de tentar observar o paciente em ambiente controlado.⁹ Exames complementares devem ser solicitados para monitorar as consequências da desnutrição ou dos comportamentos purgativos e para que sejam descartadas causas orgânicas para a perda de peso, sobretudo em pacientes com quadros atípicos, de início tardio ou que apresentem vômitos que não são autoinduzidos.¹⁰ O Quadro 22.4 relaciona algumas doenças físicas que devem ser consideradas como diagnóstico diferencial dos TAs.

QUADRO 22.4

Doenças físicas que devem ser consideradas como diagnóstico diferencial dos TAs

- Diabetes melito
- Hipertireoidismo
- Doença de Addison
- HIV/aids
- Doenças infecciosas crônicas
- Câncer
- Síndrome de má absorção
- Doenças intestinais inflamatórias crônicas

Fonte: Birmingham e Treasure.⁹

Certos transtornos mentais também podem se manifestar com alterações do comportamento alimentar, porém, com características distintas dos TAs. O Quadro 22.5 compara algumas dessas diferenças.

QUADRO 22.5

Diagnóstico diferencial da anorexia nervosa com base nas características dos sintomas alimentares

Transtorno mental	Sintoma	Comparação com sintomas alimentares da AN
Transtorno depressivo	Inapetência	Pacientes com AN recusam-se a comer por medo de engordar, e não por falta de apetite, sobretudo no início do quadro.
Síndromes psicóticas	Recusa em se alimentar	Pacientes com sintomas psicóticos podem se recusar a se alimentar por acreditarem de maneira delirante que a comida, por exemplo, está envenenada.
Transtorno obsessivo-compulsivo (TOC)	Recusa em se alimentar	Pacientes com TOC podem se negar a comer por acreditarem que o alimento está contaminado, sujo ou não foi preparado de maneira adequada.
Transtorno de ansiedade social	Medo de comer na frente de outras pessoas	Pacientes com fobia social, algumas vezes, apresentam-se muito ansiosos em situações em que têm que comer com outras pessoas, podendo, inclusive, apresentar vômitos espontâneos em tais situações.

COMPLICAÇÕES CLÍNICAS

Os transtornos alimentares estão entre as doenças psiquiátricas de maior morbimortalidade, impactando o crescimento e o desenvolvimento de pacientes adolescentes e levando a uma miríade de potenciais complicações clínicas em todas as idades.⁷ A taxa de mortalidade entre pacientes com AN é 4 a 14 vezes maior quando comparada à da população em geral,¹¹⁻¹³ sendo que 20 a 25% das mortes são causadas por suicídio.^{14,15} Em geral, os motivos pelos quais os pacientes com transtorno alimentar procuram os serviços de urgência e emergência estão relacionados aos sintomas decorrentes da desnutrição ou dos métodos purgativos, entre eles tontura, fadiga, desidratação, palpitação, desmaios, síncope e convulsões.¹⁶ Diversas são as possíveis complicações relacionadas à anorexia nervosa e à bulimia (Quadro 22.6). É fundamental que o médico esteja constantemente atento e avalie o estado clínico do paciente, para ser capaz de intervir precocemente, inclusive indicando tratamento hospitalar quando houver necessidade.

QUADRO 22.6

Possíveis complicações clínicas relacionadas à anorexia nervosa e à bulimia

Nutricionais e metabólicas	Escorbuto, índice de massa corpórea baixo, perda dos contornos do quadril e das mamas nas mulheres, deficiência de crescimento nas crianças e adolescentes, hipotermia, acidose metabólica hiperclorêmica, alcalose metabólica hipoclorêmica
Cardiovasculares	Atrofia do miocárdio, miocardiopatia, prolapso da válvula mitral, edema pericárdico, bradicardia, parada cardíaca, alterações do eletrocardiograma, hipotensão, aterosclerose, cianose de extremidades, endocardite bacteriana
Endocrinológicas	Amenorreia, hipotireoidismo, hipercortisolemia, hipoglicemia, diabetes insípido, insuficiência ovariana, diminuição da libido, infertilidade
Gastrintestinais	Retardo do esvaziamento gástrico, constipação, diarreia, síndrome da artéria mesentérica superior, hipertrofia das glândulas parótidas, síndrome de Mallory-Weiss, refluxo gastroesofágico, esôfago de Barrett
Renais e dos eletrólitos	Diminuição da filtração glomerular, insuficiência renal, creatinina sérica diminuída, nefrolitíase, diminuição da concentração urinária, edema, desidratação, hipocalemia, hipomagnesemia, hiponatremia
Pulmonares	Fraqueza na musculatura respiratória, dispneia, pneumonia, pneumotórax e pneumomediastino espontâneos
Hematológicas	Anemia normo, micro ou macrocítica, leucopenia, trombocitopenia, sangramento, equimoses
Neurológicas	Atrofia cerebral, alargamento de ventrículos, comprometimento cognitivo, neuropatia periférica, convulsão
Dermatológicas	Pele seca, lanugo, alopecia, hiper胡萝卜素emia, pelagra, estomatite angular, unhas fracas e quebradiças, sinal de Russel
Osteomusculares	Fraqueza muscular, atrofia muscular, osteoporose, fratura patológica, alterações articulares relacionadas a exercícios físicos exagerados
Odontológicas	Sangramento gengival, descalcificação, erosão e perda dentária, gengivite

Fonte: Birmingham e Treasure,⁹ Rosen e colaboradores.⁴

TRATAMENTO

Embora seja evidente o alto impacto pessoal, social e financeiro associado aos transtornos alimentares, e apesar da existência de tratamentos eficazes, apenas a minoria dos pacientes está em algum tipo adequado de tratamento. De forma geral, prevalece a impressão de que o desenvolvimento de serviços especializados se encontra ainda em fase inicial em vários países. No Brasil, tais serviços concentram-se nos Estados do Rio de Janeiro, de São Paulo e do Rio Grande do Sul e são compostos, em sua maioria, por profissionais não remunerados/voluntários. Em muito deles, constata-se grande número de pacientes que aguardam longo tempo em lista de espera até iniciarem o tratamento.¹⁷

O profissional que trabalha em hospital geral pode ser solicitado a acompanhar um paciente com TA. Mesmo o médico que se sentir preparado para lidar com um paciente que apresenta uma alteração do comportamento alimentar deve solicitar a colaboração de outros profissionais e formar uma equipe multiprofissional de tratamento. Idealmente, essa equipe deve ser constituída por nutricionista, psicólogo, terapeuta ocupacional, enfermeiro, psiquiatra e clínico, que, mais do que um saber específico, precisam ter coesão de ideias.¹⁸ A anamnese completa, que inclui informações sobre aspectos psicossociais e nutricionais, deve servir de base a qualquer planejamento terapêutico. Pacientes com transtornos alimentares, em geral, necessitam de uma ampla variedade de intervenções: tratamento das complicações clínicas, tratamento psicoterápico individual, de grupo ou familiar, aconselhamento nutricional e, quando necessário, tratamento com psicofármacos.

Os profissionais devem reconhecer que muitos desses pacientes são ambivalentes quanto ao tratamento e, portanto, devem estar preparados para lidar com desafios decorrentes dessa ambivalência. Tais pacientes podem acreditar que serão mal compreendidos ou, até mesmo, hostilizados devido à compulsão alimentar ou ao comportamento purgativo. Aqueles que já foram hospitalizados anteriormente podem ter experiências prévias negativas. Outras vezes, podem se contrapor à proposta de restauração do peso devido à crença de que a anorexia é um estilo de vida, e não uma doença, e veem qualquer intervenção terapêutica como um meio de torná-los gordos. Assim, a abordagem psicoeducacional é fundamental: pacientes e seus cuidadores devem ser informados sobre a natureza, o curso e o tratamento dos TAs. Uma postura empática, tolerante e adequadamente flexível é altamente recomendável para o desenvolvimento de uma aliança terapêutica entre paciente, seus familiares, cuidadores e os profissionais da equipe.¹⁹

Em todos os tipos de transtornos alimentares, a terapia nutricional é absolutamente necessária e exige profissionais especializados.²⁰ Na AN, as alimentações enteral e parenteral devem ser reservadas para casos de pacientes desnutridos com IMC < 15 kg/m² e em ambiente hospitalar. O tratamento psicoterápico deve fazer parte da terapêutica de pacientes com AN, BN ou transtorno de compulsão alimentar (TCA). Crianças, adolescentes e jovens, particularmente aqueles que convivem com os pais, parentes ou cuidadores, requerem psicoterapia de família. A terapia cognitivo-comportamental é a modalidade psicoterápica mais estudada e com maiores evidências de eficácia, sobretudo no tratamento da BN e do TCA.¹⁹ Até o momento, os ensaios clínicos com medicamentos não mostraram eficácia no tratamento da AN.²¹ Entretanto, os antidepressivos

inibidores da recaptação de serotonina podem ser úteis no tratamento de quadros comórbidos, como a depressão e os transtornos de ansiedade. Diferentemente da AN, a fluoxetina em doses de 60 mg/dia mostrou-se eficaz no tratamento da BN.^{22,23} Outras drogas, como a sertralina, a fluvoxamina e o topiramato, podem ser úteis, mas seu uso ainda não é respaldado por evidências científicas. A lisdexanfetamina é um pró-fármaco usado para o tratamento do transtorno de déficit de atenção/hiperatividade e foi a primeira droga aprovada pela U.S. Food and Drug Administration (FDA) para o tratamento do TCA.^{24,25} A dose máxima recomendada é 70 mg/dia, iniciando-se com 30 mg diários.

Tratamento hospitalar

Enquanto, no passado, pacientes com AN eram tratados principalmente em contexto hospitalar devido à cronicidade e às complicações relacionadas à desnutrição, ao longo das últimas décadas, tem havido uma diminuição da proporção de pacientes hospitalizados. O tratamento ambulatorial tem-se mostrado suficiente para a maioria dos pacientes, e a hospitalização, indicada para casos mais graves ou para aqueles que apresentam complicações que ponham em risco a vida do indivíduo. Alguns critérios devem ser observados para que seja indicado o tratamento hospitalar:^{1,7,9}

- hipotensão arterial grave, bradicardia FC < 40 bpm, hipotermia T < 38° C, hipoglicemia, desidratação, hipopotassemia, diabetes descontrolado, alterações hepáticas, renais ou cardíacas
- intencionalidade ou tentativa de suicídio
- perda de peso rápida (> 4 kg em 1 mês) ou IMC < 15 kg/m² ou abaixo de percentil 3 (crianças e adolescentes)
- pouca motivação e falta de cooperação do paciente ou familiares, levando a falência do tratamento ambulatorial
- outro transtorno mental comórbido que exija a hospitalização
- necessidade de supervisão durante ou após a refeição ou necessidade de alimentação enteral ou parenteral
- rede de apoio familiar ou social ausente ou instável ou conflitos familiares muito graves que impeçam o tratamento ambulatorial adequado

Os objetivos da internação são a restauração do peso até o nível mais próximo possível do normal (IMC entre 19 e 24 kg/m²), o tratamento das complicações relacionadas à desnutrição e aos comportamentos purgativos e a melhora dos hábitos alimentares patológicos e dos sintomas psicológicos do transtorno alimentar.

O nível de experiência, treinamento e coesão da equipe multidisciplinar que atende o paciente com TA é mais importante do que o tipo de hospital onde o tratamento se realiza. Embora seja preferível que a hospitalização se dê em centros especializados, em nosso meio, é no hospital geral onde muitas vezes ela ocorre, seja em enfermaria clínica, seja em psiquiátrica. Nesse caso, é fundamental a efetiva participação da equipe especializada no tratamento, cabendo a ela as seguintes funções:

- integrar-se concretamente aos profissionais da enfermagem
- auxiliar na elaboração do plano terapêutico, definindo os objetivos da internação, necessidade de medicação, terapêutica nutricional e necessidade de interconsulta de outros especialistas
- contribuir para que a comunicação com o paciente e as condutas de todos os membros sejam homogêneas e coerentes
- realizar o tratamento psicoterápico ou supervisionar o profissional que o realizará
- instrumentalizar a equipe de enfermagem para que tenha condições de avaliar os comportamentos do paciente; quando necessário, registrar como foi a aceitação da dieta, monitorar se o paciente respeita os períodos de repouso prescritos, se não pratica exercícios físicos e se não usa laxantes, vomita ou come secretamente alimentos de outros pacientes
- contribuir para que a atitude da equipe seja empática e a aliança terapêutica seja sempre fortalecida

É fundamental que a equipe tenha um coordenador que seja o responsável principal do grupo, um membro de referência da equipe para o paciente e seus familiares. Ele dialogará sobre o tratamento, seus objetivos e vicissitudes, buscando evitar, assim, as frequentes situações em que o paciente pode tentar contradizer as orientações de um membro da equipe, usando o suposto discurso de outro, às vezes até produzindo conflitos internos no grupo, com o objetivo de burlar a recuperação do peso.

A estrutura física do local de tratamento deve ser tal que impeça que o paciente tenha condições de comer, vomitar ou praticar exercícios físicos distante da observação da equipe de enfermagem. Também os enfermeiros devem estar habilitados a lidar adequadamente com as tentativas de transgredir as regras definidas no plano terapêutico e com as recusas à alimentação.

O bom vínculo entre a família e a equipe é essencial para que o tratamento siga seu melhor curso. Entretanto, a maioria dos serviços recomenda que os pacientes sejam internados sem o acompanhamento dos familiares.

Atualmente, uma opção para aqueles mais resistentes ao tratamento ambulatorial e que ainda não preenchem os critérios para uma internação completa é a internação parcial em hospitais-dia para pacientes com TA.²⁶

SÍNDROME DA REALIMENTAÇÃO

A síndrome da realimentação (SR) é uma complicação grave, previsível e evitável que pode ocorrer em virtude da realimentação em pacientes gravemente desnutridos. Essa complicação pode ocorrer secundariamente à alimentação oral e parenteral, mas o risco é maior na dieta enteral.²⁷ É causada pela queda aguda e grave dos níveis séricos de fosfato, potássio e magnésio. Esses eletrólitos deslocam-se do espaço extracelular para dentro da célula devido à insulina que se eleva a partir do aumento da glicose secundário à reintrodução dos alimentos. As consequências clínicas, que podem variar em gravidade, incluem náusea, vômito, letargia, insuficiência respiratória, arritmia e insuficiência cardíaca, hipotensão, *delirium*, coma e morte. O quadro pode se deteriorar rapidamente se as medidas apropriadas não forem tomadas em tempo. Três fatores parecem fundamentais para o manejo do quadro: a identificação precoce dos fatores de risco (Quadro 22.7),²⁸ o monitoramento e a correção dos níveis dos eletrólitos e um regime de realimentação adequado (Quadro 22.8).²⁹

QUADRO 22.7

Fatores de risco para o desenvolvimento da síndrome da realimentação

- Alcoolismo
- Anorexia nervosa
- Desnutrição grave
- Diabetes melito
- Doenças inflamatórias intestinais
- Pacientes institucionalizados
- Pacientes submetidos a cirurgia bariátrica
- Pancreatite crônica
- Pós-operatório
- Pouca ou nenhuma ingestão alimentar por sete dias ou mais
- Radioterapia
- Aids
- Síndromes disabsortivas

Fonte: Com base em Khan e colaboradores.²⁸

QUADRO 22.8

Estratégias para minimizar o risco de síndrome da realimentação em pacientes em nutrição parenteral

- Considerar que todos os pacientes estão sob alto risco de desenvolver SR.
- Considerar que os pacientes de risco muito alto para desenvolver SR têm IMC < 14 kg/m² e ingestão alimentar insuficiente por mais de 14 dias.
- Realizar a dosagem de fósforo, potássio, magnésio, cálcio e pré-albumina antes de iniciar a dieta.
- Caso necessário, corrigir as alterações eletrolíticas e de glicemia antes de iniciar a dieta.
- Iniciar a realimentação com no máximo 10 kcal/kg/dia.
- Monitorar com extrema atenção o aporte hídrico e os níveis de fósforo, potássio, magnésio e cálcio nas primeiras 48 horas, fazendo as reposições necessárias. A reposição de sódio deve ser especialmente cautelosa.
- Continuar monitorando fósforo, potássio, magnésio e cálcio diariamente nos 5 dias seguintes.

Fonte: Com base em Venecourt-Jackson e colaboradores.²⁹

O National Institute for Clinical Excellence (NICE – Reino Unido) recomenda que, para pacientes sob risco de desenvolver síndrome da realimentação, a dieta deve começar com 10 kcal/kg/dia, com aumento gradual, até atingir, em sete dias, necessidade nutricional basal. Deve-se fazer a suplementação de tiamina (vitamina B1), 200 a 300 mg/dia, desde antes do início da realimentação e pelo período de 10 dias. Deve-se monitorar de perto as dosagens sanguíneas de fósforo, potássio, magnésio e cálcio. A hidratação e a reposição dos eletrólitos devem ser feitas cuidadosamente.³⁰

TRANSTORNOS ALIMENTARES E DIABETES

O diabetes melito (DM) é uma doença caracterizada por hiperglicemia persistente resultante das anormalidades na ação e/ou secreção de insulina. O diabetes melito tipo 1 (DM1) prevalece entre a população jovem e ocorre em função da deficiência na secreção de insulina. Por sua vez, o diabetes melito tipo 2 (DM2) surge geralmente após os 40 anos, decorre da resistência periférica à insulina e relaciona-se à obesidade. O tratamento do DM baseia-se no controle rígido dos níveis glicêmicos por meio do uso de hipoglicemiantes orais, insulina, controle dietético e prática de atividades físicas adequadas. Por razões evidentes, a comorbidade entre DM e os TAs, principalmente a bulimia e o transtorno de compulsão alimentar, é motivo de grande preocupação. Há evidências de que a prevalência dos TAs entre os pacientes diabéticos seja maior do que entre indivíduos sem diabetes.³¹⁻³³ No DM2, encontram-se mais pacientes com transtorno de compulsão alimentar, enquanto entre os indivíduos com DM1 predomina a bulimia nervosa. Esses pacientes frequentemente omitem as doses de insulina para evitar o ganho de peso após um episódio de compulsão alimentar. Por isso, têm maior risco de complicações relacionadas à hiperglicemia crônica, como cetoacidose diabética e complicações microvasculares, especialmente a retinopatia e a nefropatia.³⁴ Ainda não há evidências de que estratégias terapêuticas específicas possam ser eficazes para esses pacientes, já que eles não costumam responder bem ao tratamento convencional. Entretanto, diante de pacientes diabéticos, principalmente adolescentes, que não conseguem atingir o controle glicêmico adequado, o médico deve suspeitar da coexistência de um TA e investigar, de forma objetiva, comportamentos de compulsão alimentar ou de omissão da insulina.

CIRURGIA BARIÁTRICA

Nas últimas décadas, a obesidade tornou-se, em todo o mundo, um dos principais fatores de risco para inúmeras doenças, principalmente as cardiovasculares, diabetes tipo 2 e várias neoplasias malignas, prejudicando a qualidade de vida dos indivíduos e reduzindo sua expectativa de vida.^{35,36} Vários pacientes com obesidade grave, ou de grau III, não têm boa resposta ao tratamento clínico. A cirurgia bariátrica tem-se mostrado uma técnica de grande importância na abordagem terapêutica desses pacientes. Rotineiramente, ela reduz o peso inicial em 25 a 30%, o que leva à melhora das condições mórbidas relacionadas à obesidade, da condição psicossocial e da qualidade de vida. No entanto, mudanças na saúde mental do paciente não são previsíveis como as que ocorrem normalmente na saúde física. A indicação desse tratamento cirúrgico vem crescendo nos dias atuais e depende de uma análise abrangente de múltiplos aspectos do paciente. Assim, são candidatos para o tratamento cirúrgico (cirurgia bariátrica) os pacientes com IMC maior que 40 kg/m² ou com IMC maior que 35 kg/m² associado a comorbidades (hipertensão arterial, dislipidemia, diabetes tipo 2, apneia do sono, entre outras). A seleção de pacientes requer um tempo mínimo de cinco anos de evolução da obesidade e história de insucesso do tratamento convencional realizado por profissionais qualificados. Os candidatos devem ser avaliados por equipe multiprofissional, composta geralmente por cirurgião, nutricionista, clínico, psiquiatra e psicólogo.

Dawes e colaboradores³⁷ realizaram uma metanálise em que investigaram a saúde mental de indivíduos candidatos a cirurgia bariátrica e concluíram que a prevalência de transtornos mentais nessa população é alta, sobretudo transtornos do humor (14-31%) e transtorno de compulsão alimentar (13-21%). Evidências de qualidade moderada indicam que, após a cirurgia, os pacientes apresentam melhora dos sintomas depressivos.³⁷

A decisão de contraindicar a cirurgia a pacientes que apresentam um transtorno mental é um tema controverso e deve estar vinculada à avaliação da capacidade do candidato de compreender todas as demandas do tratamento pós-operatório e de aderir ao acompanhamento multiprofissional pré-operatório.³⁶ Em alguns casos, podem existir razões psiquiátricas para atrasar a cirurgia ou não a indicar (Quadro 22.9).³⁸ Um temor muito grande em relação ao risco de um transtorno mental complicar a cirurgia de obesidade surgiu a partir de estudos de seguimento pós-operatório. Alguns deles reportaram várias condições psiquiátricas como causas de morte no período pós-operatório, sendo o suicídio a principal ocorrência. Entretanto, Dong e colaboradores³⁹ relataram que o risco de tentativa de suicídio em pessoas com IMC entre 40 e 49,9 kg/m² foi 87% maior do que entre a população em geral e 122% maior entre as pessoas com IMC igual ou maior que 50 kg/m².³⁹ Como os indivíduos estudados não eram candidatos à cirurgia bariátrica, os autores sugerem que a obesidade extrema, e não a cirurgia isoladamente, aumenta o risco de suicídio.

QUADRO 22.9

Possíveis razões psiquiátricas para atrasar a cirurgia bariátrica ou não a indicar

- Transtorno mental grave insuficientemente controlado

- Abuso ou dependência de álcool ou drogas
- Incapacidade de fornecer consentimento livre e esclarecido para a cirurgia
- Recusa em cumprir o protocolo do tratamento pós-operatório

Fonte: Com base em Marcus e colaboradores.³⁸

Os dados que relacionam a presença de transtorno mental antes da cirurgia bariátrica e a perda de peso ainda são inconsistentes.³⁷ Hsu e colaboradores,⁴⁰ ao realizarem um estudo longitudinal, demonstraram que, dos 120 pacientes obesos mórbidos avaliados, 58,3% apresentavam algum tipo de transtorno alimentar (37,5% TCA e 20,8% BN) no período pré-operatório. Na avaliação pós-operatória, observou-se que esses pacientes tinham mais dificuldades para perder peso e, em alguns casos, teriam até apresentado ganho ponderal. Pacientes com quadros depressivos parecem também ter mais dificuldade em perder peso após a cirurgia.⁴¹ Sintomas de anorexia nervosa também podem ocorrer no período pós-operatório.⁴²⁻⁴⁴ Bonne e colaboradores⁴⁵ demonstraram, por meio do relato de dois casos, que essa condição pode ocorrer como uma complicação devido à ausência de uma avaliação psiquiátrica prévia.⁴⁵

Portanto, a avaliação psiquiátrica pré-operatória é importante e deve ser realizada por um profissional habilitado, experiente e integrado a uma equipe cirúrgica multidisciplinar, pois o tratamento adequado de transtornos mentais preexistentes pode ser fundamental para o sucesso do procedimento cirúrgico.⁴⁶

REFERÊNCIAS

1. American Psychiatric Association. Diagnostic and statistical manual of mental disorders: DSM-5. Washington: APA; 2013.
2. Power P, Power L, Canadas MB. Low socioeconomic status predicts abnormal eating attitudes in Latin American female adolescents. *Eat Disord*. 2008;16(2):136-45.
3. American Psychiatric Association. Diagnostic and statistical manual of mental disorders : DSM-IV-TR. Washington: APA; 2003.
4. Rosen DS. Clinical report: identification and management of eating disorders in children and adolescents. *Pediatrics*. 2010;111(1):204.
5. Smink FR, van Hoeken D, Hoek HW. Epidemiology of eating disorders: incidence, prevalence and mortality rates. *Curr Psychiatry Rep*. 2012;14(4):406-14.
6. Swanson SA, Crow SJ, Le Grange D, Swendsen J, Merikangas KR. Prevalence and correlates of eating disorders in adolescents. Results from the national comorbidity survey replication adolescent supplement. *Arch Gen Psychiatry*. 2011;68(7):714-23.
7. Treasure J, Claudino AM, Zucker N. Eating disorders. *Lancet*. 2010;375(9714):583-93.
8. Smink FR, van Hoeken D, Hoek HW. Epidemiology, course, and outcome of eating disorders. *Curr Opin Psychiatry*. 2013;26(6):543-8.
9. Birmingham CL, Treasure J. Medical management of eating disorders. New York: Cambridge University; 2010.
10. Garcia Junior C, Araujo OF, Murro AL, Traballi AL, Andreollo NA. Idiopathic achalasia mistakenly diagnosed as anorexia nervosa. *Rev Bras Psiquiatr*. 2008;30(2):168.
11. Franko DL, Keshaviah A, Eddy KT, Krishna M, Davis MC, Keel PK, et al. A longitudinal investigation of mortality in anorexia nervosa and bulimia nervosa. *Am J Psychiatry*. 2013;170(8):917-25.
12. Hoang U, Goldacre M, James A. Mortality following hospital discharge with a diagnosis of eating disorder: national record linkage study, England, 2001-2009. *Int J Eat Disord*. 2014;47(5):507-15.
13. Suokas JT, Suvisaari JM, Gissler M, Lofman R, Linna MS, Raevuori A, et al. Mortality in eating disorders: a follow-up study of adult eating disorder patients treated in tertiary care, 1995-2010. *Psychiatry Res*. 2013;210(3):1101-6.
14. Arcelus J, Mitchell AJ, Wales J, Nielsen S. Mortality rates in patients with anorexia nervosa and other eating disorders. A meta-analysis of 36 studies. *Arch Gen Psychiatry*. 2011;68(7):724-31.
15. Sullivan PF. Mortality in anorexia nervosa. *Am J Psychiatry*. 1995;152(7):1073-4.
16. Mascolo M, Trent S, Colwell C, Mehler PS. What the emergency department needs to know when caring for your patients with eating disorders. *Int J Eat Disord*. 2012;45(8):977-81.
17. Appolinario JC, Moya T. Serviços de transtornos alimentares no Brasil e no mundo. In: Nunes MA, Appolinário JC, Galvão AL, Coutinho W, editors. *Transtornos alimentares e obesidade*. 2. ed. Porto Alegre: Artmed; 2006.

18. Nunes MA, Ávila BND. Tratamento hospitalar dos transtornos alimentares. In: Nunes MA, Appolinário JC, Galvão AL, Coutinho W, editors. Transtornos alimentares e obesidade. 2. ed. Porto Alegre: Artmed; 2006.
19. National Collaborating Centre for Mental Health. Eating disorders: core interventions in the treatment and management of anorexia nervosa, bulimia nervosa and related eating disorders. Leicester: British Psychological Society; 2004.
20. Reiter CS, Graves L. Nutrition therapy for eating disorders. *Nutr Clin Pract*. 2010;25(2):122-36.
21. Frank GK, Shott ME. The role of psychotropic medications in the management of anorexia nervosa: rationale, evidence and future prospects. *CNS Drugs*. 2016;30(5):419-42.
22. Bacaltchuk J, Hay P. Antidepressants *versus* placebo for people with bulimia nervosa. *Cochrane Database Syst Rev*. 2001(4):CD003391.
23. Bacaltchuk J, Hay P. Antidepressants *versus* placebo for people with bulimia nervosa. *Cochrane Database Syst Rev*. 2003(4):CD003391.
24. Reas DL, Grilo CM. Pharmacological treatment of binge eating disorder: update review and synthesis. *Expert Opin Pharmacother*. 2015;16(10):1463-78.
25. Guerdjikova AI, Mori N, Casuto LS, McElroy SL. Novel pharmacologic treatment in acute binge eating disorder: role of lisdexamfetamine. *Neuropsychiatr Dis Treat*. 2016;12:833-41.
26. Guimarães DBS, Salzano FT, Abreu CND. Indicações para internação hospitalar completa ou parcial. *Rev Bras Psiquiatr*. 2002;24(3):60-2.
27. Koletzko B. 3.22 Nutrition rehabilitation in eating disorders. *World Rev Nutr Diet*. 2015;113:259-65.
28. Khan LU, Ahmed J, Khan S, Macfie J. Refeeding syndrome: a literature review. *Gastroenterol Res Pract*. 2011;2011.
29. Venecourt-Jackson E, Hill SJ, Walmsley RS. Successful treatment of parenteral nutrition associated liver disease in an adult by use of a fish oil-based lipid source. *Nutrition*. 2013;29(2013):356-8.
30. National Collaborating Centre for Mental Health. Nutrition support in adults: oral nutrition support, enteral tube feeding and parenteral nutrition [Internet]. London: National Collaborating Centre for Acute Care at The Royal College of Surgeons of England; 2006 [capturado em 05 fev.2017]. Disponível em: <https://www.nice.org.uk/guidance/cg32/evidence/full-guideline-194889853>.
31. Young V, Eiser C, Johnson B, Brierley S, Epton T, Elliott J, et al. Eating problems in adolescents with type 1 diabetes: a systematic review with meta-analysis. *Diabet Med*. 2013;30(2):189-98.
32. Pinhas-Hamiel O, Hamiel U, Levy-Shraga Y. Eating disorders in adolescents with type 1 diabetes: challenges in diagnosis and treatment. *World J Diabetes*. 2015;6(3):517-26.
33. Garcia-Mayor RV, Garcia-Soidan FJ. Eating disorders in type 2 diabetic people: brief review. *Diabetes Metab Syndr*. 2016;S1871-4021(16)30150-3.
34. Treasure J, Kan C, Stephenson L, Warren E, Smith E, Heller S, et al. Developing a theoretical maintenance model for disordered eating in type 1 diabetes. *Diabet Med*.

2015;32(12):1541-5.

35. Haslam DW, James WPT. Obesity. *Lancet*. 2005;366(9492):1197-209.
36. Yen YC, Huang CK, Tai CM. Psychiatric aspects of bariatric surgery. *Curr Opin Psychiatry*. 2014;27(5):374-9.
37. Dawes AJ, Maggard-Gibbons M, Maher AR, Booth MJ, Miake-Lye I, Beroes JM, et al. Mental health conditions among patients seeking and undergoing bariatric surgery: a meta-analysis. *JAMA*. 2016;315(2):150-63.
38. Marcus MD, Kalarchian MA, Courcoulas AP. Psychiatric evaluation and follow-up of bariatric surgery patients. *Am J Psychiatry*. 2009;166(3):285-91.
39. Dong C, Li WD, Li D, Price RA. Extreme obesity is associated with attempted suicides: results from a family study. *Int J Obes*. 2006;30(2):388-90.
40. Hsu LK, Betancourt S, Sullivan SP. Eating disturbances before and after vertical banded gastroplasty: a pilot study. *Int J Eat Disord*. 1996;19(1):23-34.
41. de Zwaan M, Enderle J, Wagner S, Muhlhans B, Ditzgen B, Gefeller O, et al. Anxiety and depression in bariatric surgery patients: a prospective, follow-up study using structured clinical interviews. *J Affect Disord*. 2011;133(1-2):61-8.
42. Atchison M, Wade T, Higgins B, Slavotinek T. Anorexia nervosa following gastric reduction surgery for morbid obesity. *Int J Eat Disord*. 1998;23(1):111-16.
43. Guisado JA, Vaz FJ, Lopez-Ibor JJ, Lopez-Ibor MI, del Rio J, Rubio MA. Gastric surgery and restraint from food as triggering factors of eating disorders in morbid obesity. *Int J Eat Disord*. 2002;31(1):97-100.
44. Deitel M. Anorexia nervosa following bariatric surgery. *Obes Surg*. 2002;12(6):729-30.
45. Bonne OB, Bashi R, Berry EM. Anorexia nervosa following gastroplasty in the male: two cases. *Int J Eat Disord*. 1996;19(1):105-8.
46. Segal A, Fandiño J. Indicações e contraindicações para realização das operações bariátricas. *Rev Bras Psiquiatr*. 2002;24:68-72.



Psicofármacos: conceitos básicos

Amilton dos Santos Júnior
Neury José Botega
Osmar Henrique Della Torre

Psicofarmacologia é a área da farmacologia que estuda o uso de medicamentos para o manejo de sintomas mentais e comportamentais. Os profissionais envolvidos com a prescrição de psicofármacos devem estar atualizados, não apenas quanto às indicações, mas também em relação a farmacocinética, farmacodinâmica, possíveis interações, pesquisa e segurança dos medicamentos utilizados. Também é desejável que profissionais não médicos possam entender conceitos básicos a respeito da ação dos medicamentos utilizados em psiquiatria. Este capítulo versa sobre princípios gerais e elementos-chave do uso racional e terapêutico de psicofármacos na prática clínica, bem como sobre informações a respeito das etapas de estudos de desenvolvimento de novos fármacos, além de trazer sugestões de sites e aplicativos para pesquisa de interações medicamentosas. Para o médico, o texto traz uma síntese do que ele deve ter estudado em farmacologia; para o não médico, informações básicas que possam favorecer o entendimento. O aprofundamento sobre o uso de psicofármacos em situações clínicas especiais é encontrado no Capítulo 26, e informações sobre efeitos adversos e de intoxicações, no Capítulo 25.

Os psicofármacos eram classificados em quatro categorias básicas, com os seguintes “nomes de batismo”:

- a) antipsicóticos ou neurolépticos;
- b) antidepressivos;
- c) estabilizadores do humor; e
- d) ansiolíticos/hipnóticos.¹

Atualmente, é preferível que sejam discutidos de acordo com suas ações farmacológicas, pelas seguintes razões:

- medicamentos de uma classe podem ser usados para o tratamento de sintomas para os quais inicialmente eram usados fármacos de outra classe, como antidepressivos em transtornos de ansiedade
- existem condições, alvos de atenção medicamentosa, que, anteriormente, não eram consideradas problemas, como controle de impulsos e agressividade, sintomas obsessivo-compulsivos, etc.
- há psicofármacos que não se encaixam nas categorias clássicas, como os psicoestimulantes, os anticolinesterásicos ou os inibidores glutamatérgicos
- a psicofarmacologia incorporou drogas que eram primariamente usadas por outras especialidades: anticonvulsivantes no tratamento do transtorno bipolar, propranolol na ansiedade social, etc.

As ações de um psicofármaco são descritas em termos de suas propriedades farmacodinâmicas e farmacocinéticas. De modo simplificado, a farmacodinâmica descreve os efeitos dos medicamentos sobre as atividades biológicas do organismo, e a farmacocinética, como o organismo lida com um medicamento.

FARMACODINÂMICA

Para a maior parte dos medicamentos, o efeito farmacológico é o resultado de uma cadeia complexa de eventos, começando com a interação do fármaco com o receptor. A resposta farmacodinâmica é modificada por doenças, envelhecimento e outros medicamentos. Por exemplo, a presença da doença de Parkinson aumenta a incidência de transtornos do movimento induzidos por antipsicóticos.²

Circuitos cerebrais

Ao longo da vida, os neurônios modificam suas conexões sinápticas em resposta à programação genética, à aprendizagem, à fase do desenvolvimento, aos acontecimentos traumáticos, a drogas e a doenças. Alterações da estrutura e do funcionamento cerebrais são encontradas em vários transtornos psiquiátricos associados a um desenvolvimento anormal ou à degeneração dos neurônios. Tais alterações afetam a neurotransmissão, que é a base da psicofarmacologia.

A neurotransmissão inicia-se como um processo elétrico, ao longo do axônio de um neurônio. Já a comunicação de um neurônio com outro neurônio é um processo químico (transdução) que se dá por meio dos neurotransmissores – pequenas moléculas liberadas no espaço entre dois neurônios (fenda sináptica).

Neurotransmissores são aminas ou aminoácidos de baixo peso molecular. A lista de neurotransmissores atinge várias dezenas. Os que participam mais ativamente da regulação dos circuitos cerebrais são a dopamina, a serotonina, a noradrenalina, a acetilcolina, o ácido gama-aminobutírico (GABA) e o glutamato. Em conjunto, constituem os clássicos seis neurotransmissores, sobre os quais age a maioria dos psicofármacos disponíveis.

Circuitos de neurotransmissão interconectam milhares de neurônios em uma rede capaz de processar informações (*inputs*) relativamente simples e produzir respostas (*outputs*) complexas, o que constitui a função essencial do cérebro humano.

Tomando por base o conjunto de vias de neurotransmissão e sua interdependência, busca-se o entendimento da fisiopatologia dos sintomas psiquiátricos. Em geral, um sintoma está mais ligado a um ou outro circuito, que, por sua vez, é modulado mais pronunciadamente por um neurotransmissor específico. A Figura 23.1 esquematiza os principais circuitos serotoninérgicos.³

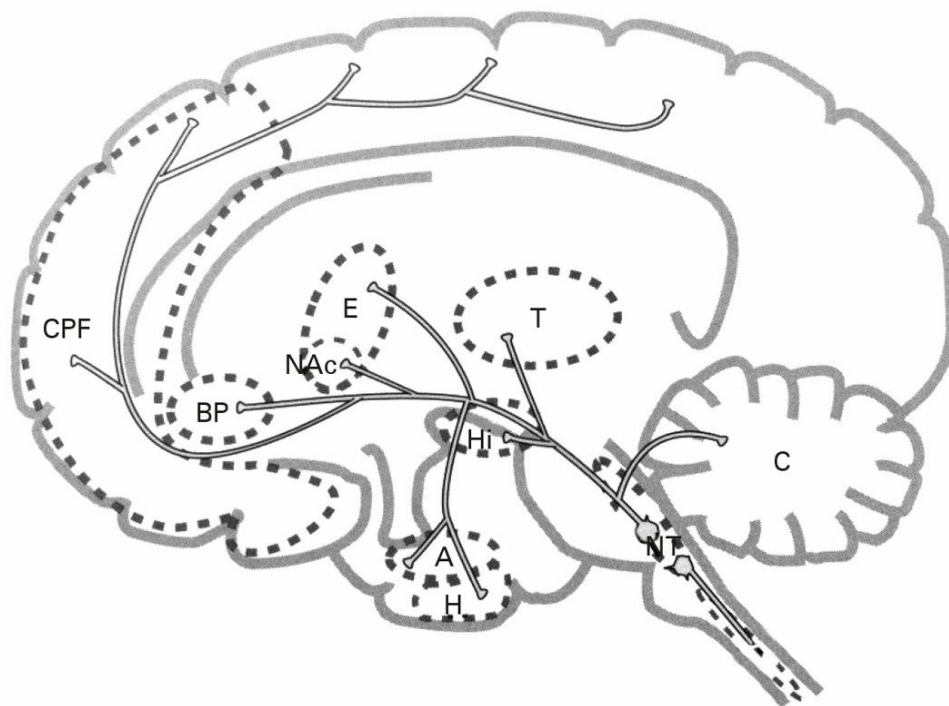


FIGURA 23.1 Principais circuitos serotoninérgicos.

A, amígdala; BP, parte basal do prosencéfalo; C, cerebelo; CPF, córtex pré-frontal; E, estriado; Hc, hipocampo; Ht, hipotálamo; ME, medula espinal; NAc, *nucleus accumbens*; T, tálamo; TE, tronco encefálico.

Fonte: Com base em Stahl.³

Esse conhecimento tem sido considerado tão importante que, em 2010, o National Institute of Mental Health, dos Estados Unidos, anunciou a intenção de produzir um sistema diagnóstico próprio, o Research Domain Criteria (RDoC), que pretende ser uma classificação nosológica informada pela neurociência, em que os comportamentos são mapeados em circuitos do cérebro específicos e inter-relacionados. Em vez de classificar um transtorno mental por seus sintomas, ele seria caracterizado pelos circuitos neurais afetados e potencialmente alvos de intervenções farmacológicas. Por exemplo, preocupações obsessivas e ansiosas poderiam ser descritas como alterações particulares no circuito córtico-estriado-tálamo-cortical.^{4,5}

Pontos nodais desses circuitos localizam-se em regiões cerebrais específicas, o que exige conhecimento básico de neuroanatomia funcional. A Figura 23.2 exemplifica os pontos nodais relacionados à fisiopatologia da depressão.

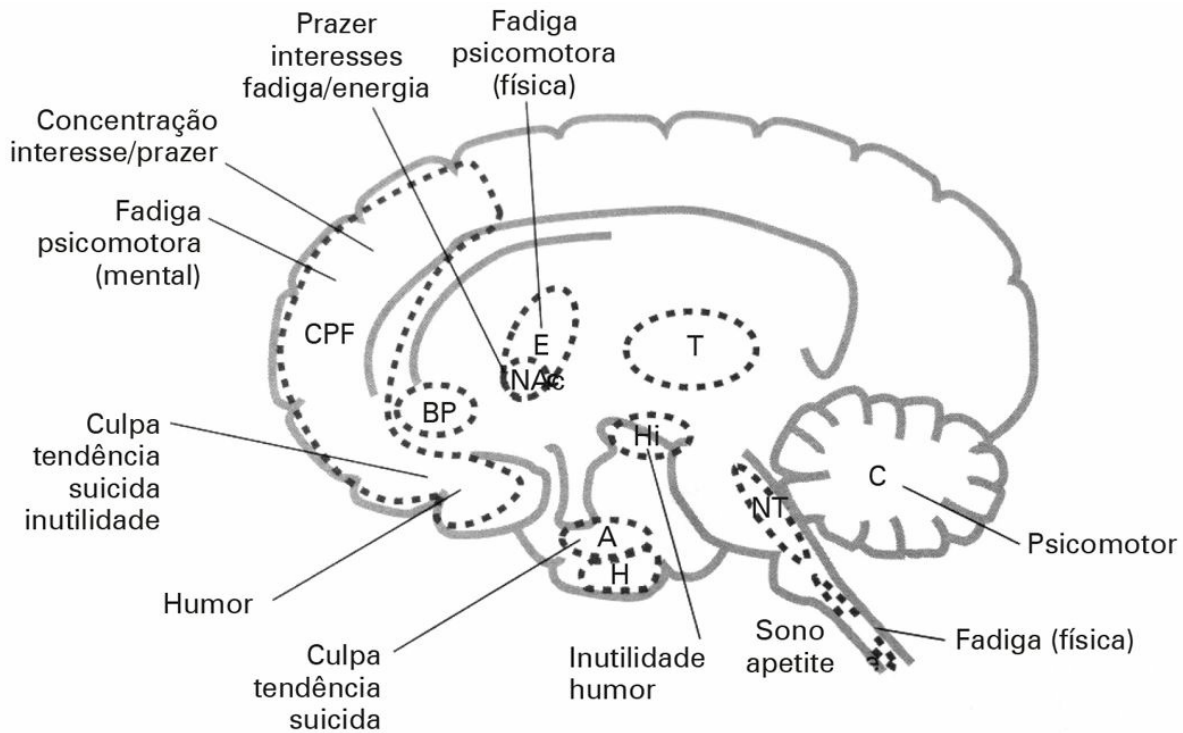


FIGURA 23.2 Pontos nodais de circuitos cerebrais hipoteticamente disfuncionais associados aos sintomas depressivos.

A, amígdala; BP, parte basal do prosencéfalo; C, cerebelo; CPF, córtex pré-frontal; E, estriado; Hc, hipocampo; Ht, hipotálamo; NAc, *nucleus accumbens*; T, tálamo.

Fonte: Com base em Stahl.³

Uma área especialmente importante para o comportamento é o córtex pré-frontal, em que a região dorsolateral controla as funções executivas, e a ventromedial, as emoções. A parte dorsal do giro anterior do cíngulo associa-se à atenção seletiva, e o córtex orbitofrontal, à impulsividade.³ No Capítulo 10, “Interconsulta de pacientes idosos”, encontra-se uma ilustração gráfica e o aprofundamento dessa temática.

Alvos e mecanismos de ação

Por meio de vários mecanismos de ação, os psicofármacos agem em alvos moleculares, como receptores neuronais, proteínas transportadoras de neurotransmissores, canais iônicos de sódio e de cálcio e enzimas. Os modos como produzem seus efeitos também são distintos e precisam ser conhecidos, porque determinam tanto seus efeitos terapêuticos quanto adversos. A ação agonista em um receptor ocorre quando o psicofármaco age estimulando a ação de um dado receptor. A ação antagonista, em contrapartida, é quando o psicofármaco não tem ação própria sobre seus sítios moleculares de ligação ao receptor, porém impede a ação de um agonista endógeno. Existem, ainda, os chamados agonistas parciais – trata-se de fármacos que podem ser agonistas ou antagonistas, dependendo do funcionamento dos neurotransmissores em seus sítios de ação.³

Os efeitos imediatos de um medicamento são resultado de uma interação direta com o receptor. Os benzodiazepínicos (p. ex., diazepam e alprazolam) têm efeitos terapêuticos imediatos e, portanto, são úteis no tratamento agudo. No caso dos antipsicóticos (p. ex., haloperidol e olanzapina), o bloqueio de receptores de dopamina diminui a intensidade do estímulo desse neurotransmissor nas sinapses e explica tanto os efeitos terapêuticos quanto os adversos (p. ex., parkinsonismo) dessa classe de psicofármacos.

Aproximadamente um terço dos psicofármacos tem como alvo os receptores ligados ao sistema da proteína G, localizado na membrana plasmática do neurônio. Por meio desse sistema, a informação vinda de um neurônio pré-sináptico é recebida pelo receptor de um neurônio pós-sináptico. O agente dessa transmissão de informação é o neurotransmissor (primeiro mensageiro). Depois de chegar ao neurônio pós-sináptico, o estímulo ativa uma molécula no interior da célula (segundo mensageiro), que, por sua vez, ativa outras moléculas (terceiro e quarto mensageiros, etc.).

Assim, a informação vai passando de molécula para molécula, em uma série de reações em cascata, até chegar à síntese de fosfoproteínas e a uma resposta biológica específica, ligada à expressão de genes. Trata-se, em um nível genético, de uma conversa de DNA para DNA, de um centro de comando pré-sináptico (começando pela síntese de neurotransmissores) para um centro de comando pós-sináptico, onde se dão o processamento da informação e a produção de efeitos, desde os moleculares até os comportamentais.³

Nem sempre os efeitos são imediatos. Muitos medicamentos psicoativos devem ser usados durante vários dias ou semanas para uma resposta terapêutica significativa, pois atuam por meio de processos celulares de adaptação lenta (Fig. 23.3). É o caso dos antidepressivos e dos estabilizadores do humor. Infelizmente, muitos efeitos adversos desses medicamentos aparecem de forma imediata – resultado de uma interação direta com o receptor. A adesão ao tratamento pode ser prejudicada quando efeitos adversos são experimentados antes de os efeitos terapêuticos serem percebidos. No Capítulo 2, sobre reação à doença e à hospitalização, encontram-se outros fatores que podem reduzir a adesão de pacientes ao uso de psicofármacos.

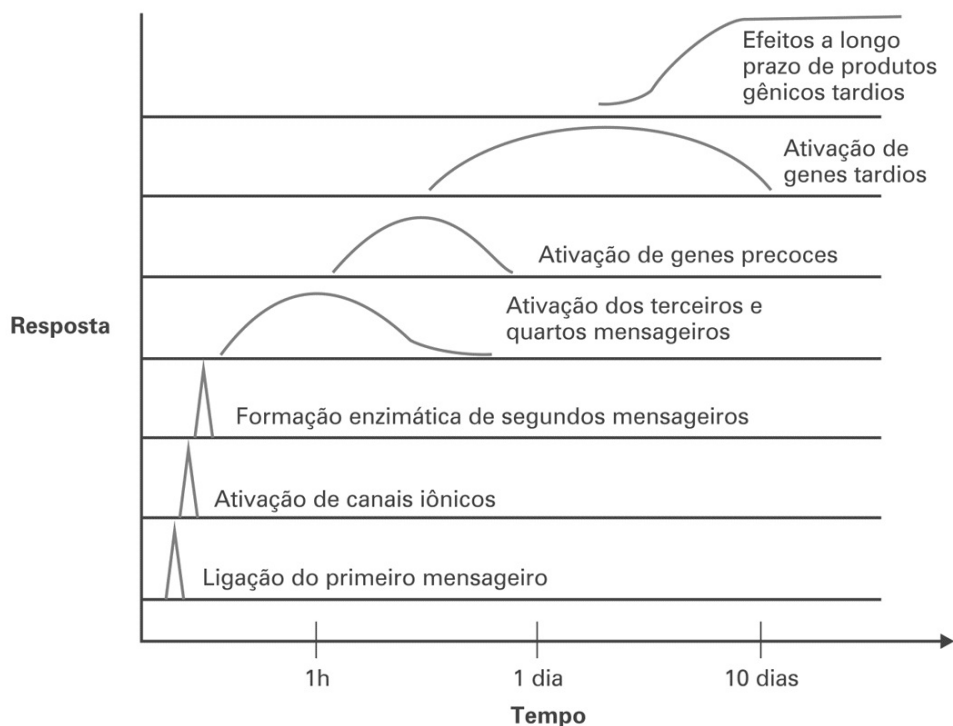


FIGURA 23.3 Sequência da transdução de sinais ao longo do tempo.

Fonte: Com base em Stahl.³

Aproximadamente, outro terço dos psicofármacos age em proteínas transportadoras de neurotransmissores. Para serem recaptados da fenda sináptica, os neurotransmissores precisam atravessar a membrana celular e, de volta ao neurônio pré-sináptico, ser armazenados nas vesículas sinápticas. A maioria dos antidepressivos bloqueia a recaptação de serotonina, de noradrenalina ou de ambas, o que resulta em aumento dessas monoaminas nas sinapses.

Medicamentos utilizados no transtorno de déficit de atenção/hiperatividade (metilfenidato) e na hipersonia (modafinil), bem como certas drogas de abuso (cocaína, anfetamina, *ecstasy*), estimulam o transporte de dopamina e noradrenalina, tanto na membrana celular quanto nas vesículas sinápticas.

A inibição enzimática é a base da ação de certos medicamentos utilizados na depressão (a tranilcipromina inibe a monoaminoxidase [MAO]) e na doença de Alzheimer (rivastigmina, donepezila e galantamina inibem a acetilcolinesterase). Nos dois casos, o resultado é o aumento da disponibilidade de neurotransmissores na sinapse (monoaminas e acetilcolina, respectivamente).

Os efeitos bioquímicos até aqui descritos ocorrem em um período de horas a dias após o início da neurotransmissão e podem perdurar por dias ou semanas, ou mesmo por toda a vida. Cada elo dessa sequência de eventos é, potencialmente, passível de alteração ocasionada por um psicofármaco. A maioria das drogas disponíveis atua no início do processo, especialmente nos receptores de neurotransmissores. Futuramente, novas drogas poderão interferir em outras etapas da neurotransmissão.

Variações de resposta

A curva de dose-resposta é a representação gráfica da resposta clínica para um determinado fármaco, em função de sua concentração. A Figura 23.4 exemplifica as curvas de dois medicamentos. No caso da fluoxetina (A), a partir da dose terapêutica mínima (em geral entre 10-20 mg), a curva torna-se relativamente plana, mostrando que, em termos de eficácia, não há vantagem em se utilizarem doses mais altas do que as recomendadas (20-40 mg/dia).⁶ A curva de resposta do metilfenidato (B), por sua vez, foi descrita como tendo um formato de U invertido, ou seja, concentrações séricas maiores desse fármaco não apenas não trazem vantagens adicionais como também cessam os efeitos terapêuticos, além de envolverem o risco de efeitos adversos.⁷ Durante a titulação do metilfenidato, normalmente se inicia com 5 mg, 1 ou 2 vezes ao dia, aumentando a cada semana em 5 a 10 mg até a máxima melhora clínica.

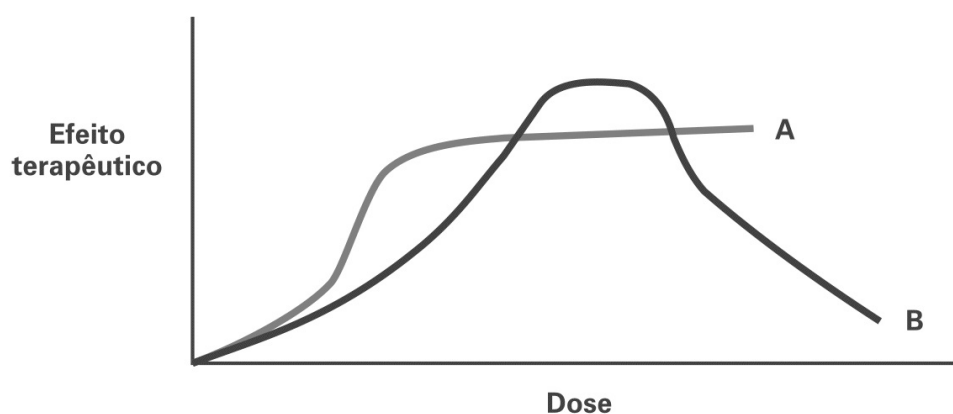


FIGURA 23.4 Curvas dose-resposta da fluoxetina e do metilfenidato.

“Potência” é um termo que se refere a comparações das dosagens de diferentes medicamentos necessários para atingir um determinado efeito. Por exemplo, o haloperidol é mais potente do que a clorpromazina, porque cerca de 2 mg de haloperidol são necessários para atingir o mesmo efeito terapêutico de 100 mg de clorpromazina. No entanto, clorpromazina e haloperidol são iguais em termos de eficácia clínica, pois alcançam a mesma resposta clínica máxima.

As variações de resposta a um psicofármaco são observadas entre os indivíduos e, dependendo de certas condições, em um mesmo indivíduo. Um indivíduo pode ser pouco reativo, normalmente reativo ou hiper-reativo para um fármaco em particular. Por exemplo, enquanto algumas pessoas necessitam de 50 mg/dia de sertralina, outras pessoas necessitam de 200 mg/dia para o controle de seus sintomas. É por isso que, em geral, é uma boa prática iniciar o tratamento com uma dose menor e, se necessário, aumentá-la progressivamente.^{1,8}

Em um mesmo indivíduo, variações de resposta podem ser observadas na dependência de certos estados fisiológicos (gestação, lactação, uso de medicamentos em jejum ou após se alimentar, entre outras situações) ou patológicos (doenças, desidratação, desnutrição). Diante da ausência de resposta a um dado psicofármaco, alguns fatores devem ser pesquisados. Variações de resposta também dependem do período da vida e de padrões específicos de neurodesenvolvimento. A densidade de diversos receptores tende a ser diferente nos anos pré-escolares se comparada à de indivíduos adultos.⁹ A exemplo disso, embora antidepressivos

tricíclicos sejam bastante efetivos no tratamento de adultos deprimidos, eles não têm efeitos demonstrados em crianças.¹⁰ Estimulantes anfetamínicos tendem a ser menos tolerados e eficazes entre os 3 e 5 anos de idade¹¹ e a causar efeitos adversos de euforia com frequência maior em adultos do que em crianças.¹²

Quando o padrão do neurodesenvolvimento é anormal, também pode haver impacto nos efeitos das medicações, como é o caso da falta de benefícios dos inibidores seletivos da recaptação de serotonina para comportamentos compulsivos e repetitivos em indivíduos com transtornos do espectro autista.¹³

Os psicofármacos podem, embora não seja a ocorrência mais comum, provocar respostas imprevisíveis, não relacionadas à dosagem, o que é conhecido como resposta idiossincrásica. Por exemplo, benzodiazepínicos, administrados como ansiolíticos ou hipnóticos, paradoxalmente podem provocar agitação em algumas pessoas.

O índice terapêutico é uma medida relativa da toxicidade ou da segurança de um psicofármaco. É definido como a comparação entre a quantidade de um agente necessária para causar um efeito terapêutico e a quantidade que causa efeitos tóxicos. Fármacos com baixos índices terapêuticos, como o lítio, precisam ser monitorados em relação a suas concentrações plasmáticas, para evitar quadros de toxicidade.

Para melhor compreensão dos fenômenos de tolerância, dependência e abstinência, recomendamos a leitura do Capítulo 19, sobre transtornos decorrentes do uso de substâncias psicoativas. Um maior detalhamento sobre sintomas de abstinência de certas drogas de abuso pode ser encontrado no Capítulo 21, e sobre abstinência de psicofármacos específicos, no Capítulo 25.

FARMACOCINÉTICA

Absorção

O tempo entre a administração de uma droga e o alcance do pico de sua concentração plasmática varia de acordo com a via de administração e a taxa de absorção. Quando os psicofármacos são administrados por via oral (VO), eles se dissolvem no fluido do trato gastrointestinal. A absorção para a corrente sanguínea depende da motilidade e da área de superfície do trato, do pH do meio e da solubilidade lipídica do próprio fármaco. Alimentos e outros medicamentos utilizados podem alterar a absorção, aumentando-a ou reduzindo-a, por influírem na acidez ou na motilidade gastrointestinal. A absorção de bupropiona, sertralina e ziprasidona tende a ser maior na presença de alimentos, enquanto o oposto pode ocorrer com alguns anticonvulsivantes.¹⁴

A maior parte dos psicofármacos é constituída de comprimidos e cápsulas que se dissolvem em minutos após a ingestão, ou seja, são formulações de liberação imediata.¹⁵ Existem, ainda, fármacos que não precisam ser ingeridos, dissolvendo-se na cavidade oral e sendo absorvidos por via sublingual (SL).

Outras formulações se dissolvem mais lentamente, referidas como de liberação prolongada (p. ex., XR e CR, de *extended* e *controlled release*, respectivamente); podem ter vantagens e desvantagens em relação às de liberação imediata (Quadro 23.1). No caso da trazodona, por exemplo, a formulação de absorção mais lenta reduz os riscos de hipotensão ortostática e de sedação excessiva, permitindo o uso de doses mais altas em quadros depressivos. Para o manejo da insônia, porém, recomendam-se doses baixas da formulação de liberação imediata, pois a sedação passa a ser o efeito almejado.¹⁶

QUADRO 23.1

Vantagens e desvantagens de comprimidos e cápsulas de liberação prolongada*

Vantagens:

- Possibilidade de tomada única diária, melhorando a adesão.
- Maior uniformidade de concentrações sanguíneas.
- Menor risco de efeitos adversos, perda de eficácia e sintomas de abstinência.
- No caso de crianças, possibilidade de não precisar tomar o medicamento na escola, o que pode causar constrangimento, estigma e experiências de *bullying*.

Desvantagens:

- Em muitos pacientes e em situações em que a motilidade gastrointestinal é acelerada, a droga pode chegar ao cólon, em que a absorção é bem menor, sendo parcialmente liberada nas fezes.
- Os custos da medicação tendem a ser mais altos.
- O tamanho do comprimido também tende a ser maior, o que pode ser problemático em pacientes com dificuldade de deglutição, em idosos e em crianças.

* Há uma profusão de siglas utilizadas para identificar os termos em inglês que correspondem às medicações de liberação prolongada. As mais usadas são: *TR* – *timed release*; *DR* – *delayed release*; *SR* – *sustained release*; *CD* – *controlled delivery*; *CR* – *controlled release*; *ER*, *XL*, *XR* e *XRO* – *extended release*; *LA* – *long acting*.

Fonte: Com base em Andrade.¹⁵

A via intramuscular (IM) e, principalmente, a via intravenosa (IV) são os percursos mais rápidos para alcançar as concentrações sanguíneas terapêuticas, mas também têm o maior risco de efeitos adversos.^{1,17}

Algumas drogas são deliberadamente emulsionadas em uma matriz de suporte insolúvel para administração IM, o que resulta em liberação gradual, de duração prolongada, ao longo de várias semanas. Essas formulações são chamadas de preparações de depósito. Diversos antipsicóticos têm preparações de depósito, sendo injetados a cada 1 a 6 semanas. Essas preparações permitem a liberação de concentrações estáveis do componente ativo, sendo muito úteis para pacientes com dificuldade de aderir ao tratamento por via oral. Todavia, devido à impossibilidade de redução de doses após a administração, existe o risco de provocarem efeitos adversos também de duração prolongada e, por isso, não devem ser administradas antes de se avaliar a resposta do paciente com formulações tradicionais dos mesmos medicamentos.^{18,19}

Para muitos pacientes, existe o receio adicional de se sentirem controlados, ou mesmo punidos, pelos médicos que lhes prescrevem tais formulações. É importante que o médico se esforce em esclarecer ao paciente e a seus cuidadores sobre os contextos e as justificativas de se utilizar essa importante via de administração, quando for o caso.

Distribuição

Uma vez na corrente sanguínea, as moléculas dos fármacos podem circular ligadas às proteínas plasmáticas ou de forma livre. Somente a fração livre pode penetrar no cérebro, depois de atravessar a barreira hematoencefálica. Diferentes fármacos apresentam diferentes graus de ligação a proteínas plasmáticas, fenômeno que também depende das concentrações plasmáticas de albumina e de outras proteínas, bem como da presença de outros compostos, que possam deslocar os medicamentos de seus sítios de ligação proteica. A gestação, os estados de desnutrição e doenças como a cirrose e a pancreatite reduzem a albuminemia.

A distribuição de um fármaco no cérebro é governada pelo fluxo sanguíneo cerebral, pela barreira hematoencefálica e pela afinidade do fármaco com seus receptores cerebrais. Medicamentos mais lipossolúveis têm mais facilidade de cruzar a barreira hematoencefálica.^{1,17}

O termo “volume de distribuição” (V_d) de um medicamento refere-se à relação entre a dose biodisponível da medicação e sua concentração plasmática. Trata-se de uma medida do espaço aparente no organismo, disponível para conter a droga, e pode variar com idade, sexo, ligação a proteínas plasmáticas, quantidade de tecido adiposo e presença de doenças.¹ O V_d elevado indica que a droga tende a ter alta afinidade por lipídeos e que é distribuída a várias partes do corpo, com a permanência de pequena fração no sangue.²⁰

Drogas hidrofílicas, como o lítio e o valproato, e aquelas com alta ligação a proteínas plasmáticas, por sua vez, tendem a ter um baixo V_d . Condições que causam edemas tendem a aumentar o V_d de medicamentos mais hidrossolúveis por expandirem o volume de líquido extracelular. A obesidade, por sua vez, é uma condição que aumenta o V_d dos medicamentos com mais afinidade a lipídeos.²⁰

“Biodisponibilidade” é um termo que se refere à fração da quantidade total de fármaco administrado que pode ser subsequentemente recuperada a partir da corrente sanguínea. Por definição, quando uma medicação é administrada por via intravenosa, sua biodisponibilidade é de 100%, uma vez que não sofre o efeito de primeira passagem.²¹

Metabolismo

O fígado é o principal órgão das rotas metabólicas de biotransformação, preparando uma droga para a excreção. “Efeito de primeira passagem” é um termo que se refere à metabolização do fármaco pelo fígado e, em menor escala, pela microbiota intestinal, antes que ele chegue à circulação sistêmica (Fig. 23.5). As vias de administração sujeitas a tal efeito são a via oral e, em proporções bem reduzidas, a via retal.²¹

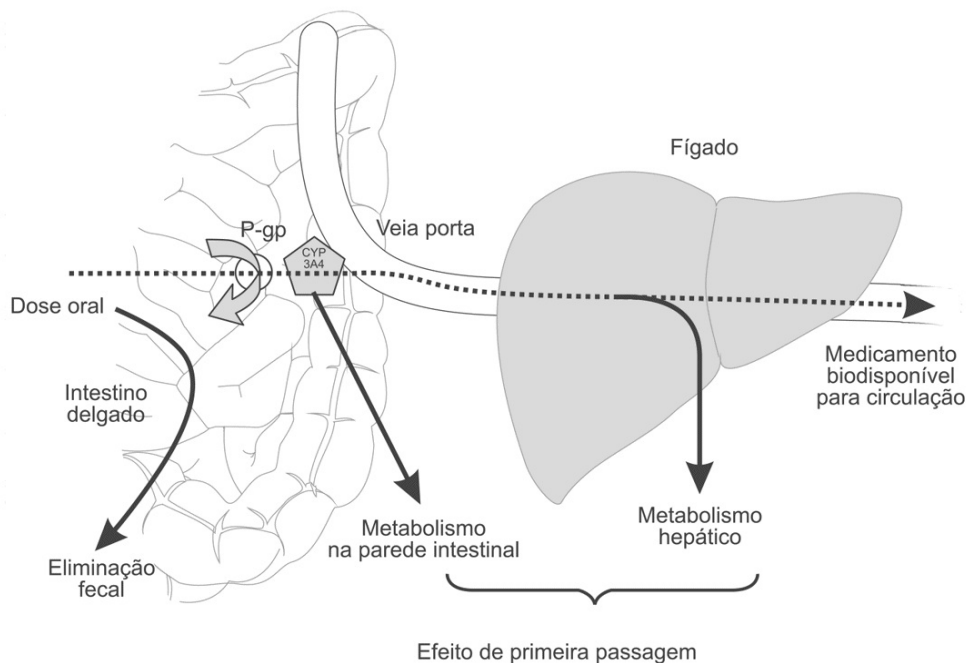


FIGURA 23.5 Metabolismo de primeira passagem por medicamentos administrados por via oral.

As quatro principais rotas de metabolização hepática ocorrem nas chamadas fase 1 (oxidação, redução e hidrólise) e fase 2 (conjugação). A fase 1 não é um processo obrigatório e varia para cada droga. A fase 2, por sua vez, é obrigatória a todas as drogas.²¹ O fato de depender de apenas uma ou de ambas as fases tem implicações importantes quando um medicamento precisa ser usado em pacientes com patologias do fígado (ver seção “Insuficiência hepática”, no Cap. 24).

A metabolização geralmente produz compostos inativos, que são rapidamente excretados. No entanto, também pode transformar muitas pró-drogas inativas em metabólitos terapeuticamente ativos, como a lisdexanfetamina, metabolizada em anfetamina, ou ainda drogas ativas em metabólitos também ativos, como a venlafaxina, convertida a desvenlafaxina, ou a risperidona, convertida a 9-hidróxi-risperidona.¹

O complexo enzimático do citocromo P450 (CYP) é responsável pela metabolização da maior parte dos psicofármacos. Seu nome deriva do fato de que suas enzimas absorvem fortemente a luz em comprimentos de onda de 450 nm. Embora estejam presentes por todo o corpo, essas enzimas atuam principalmente no retículo endoplasmático das células do fígado (hepatócitos) e do intestino, de modo que doenças como hepatite viral ou cirrose podem afetar a eficiência do metabolismo dos psicofármacos.²²

As enzimas do citocromo compreendem várias famílias e subfamílias distintas. Na nomenclatura, a família está indicada por um número, a subfamília, por uma letra maiúscula, e o membro individual da subfamília, por um segundo numeral (p. ex., 2D6 e 3A4). Pessoas com polimorfismos genéticos nos genes que codificam versões ineficientes dessas enzimas são consideradas metabolizadores lentos (ver Quadro 23.2).

QUADRO 23.2

O papel da farmacogenética

- Com o avanço de técnicas moleculares e do mapeamento do código genético, sabe-se, atualmente, que a resposta terapêutica e a suscetibilidade à ocorrência de efeitos colaterais ou interações medicamentosas estão sujeitas a diversos fatores genéticos e epigenéticos.
- Fatores epigenéticos são aqueles relacionados à regulação da expressão ou supressão gênica em função de determinados estímulos ambientais.
- Aspectos genéticos e epigenéticos podem se associar às ações psicofarmacológicas por influências farmacocinéticas ou farmacodinâmicas.
- As pessoas têm polimorfismos genéticos diferentes para o gene CYP2D6, responsável pela síntese de enzimas do complexo do citocromo P450. Essas variações as tornam metabolizadores lentos, rápidos ou ultrarrápidos das drogas que são biotransformadas por vias relacionadas a esse complexo.
- Nos Estados Unidos, o órgão regulatório Food and Drug Administration (FDA) utiliza conhecimentos farmacogenéticos para documentar diversos genes que influenciam as ações de psicofármacos.^{24,25}

Álcool, cigarro e alguns medicamentos podem induzir a atividade de determinados componentes do citocromo, acelerando suas atividades de metabolização, enquanto outros medicamentos podem inibi-la. Quando, por exemplo, um paciente é internado em uma enfermaria e para de fumar abruptamente, essa indução deixa de ocorrer, podendo aumentar a concentração sérica e, por conseguinte, o risco de efeitos adversos de vários fármacos que esteja utilizando, como clozapina, olanzapina, amitriptilina, duloxetina, fluvoxamina, haloperidol, imipramina, paracetamol, varfarina, clopidogrel, propranolol, ondansetrona, ciclofosfamida, efavirenz, entre outros.²³

Excreção

A quantidade do fármaco excretado do corpo em um dado período de tempo indica sua depuração (*clearance*). Pela excreção, os compostos são removidos do organismo para o meio externo. Enquanto o fígado é o principal órgão de metabolização de psicofármacos, a excreção é uma função realizada principalmente pelos rins. Doenças renais e idade avançada, que reduzem a função renal, aumentam o tempo de excreção das drogas, fazendo suas doses precisarem ser, em muitos casos, reduzidas. Além da urina, a bile e as fezes são vias de excreção e, em menor escala, também o suor, a saliva, as lágrimas e o leite materno.^{1,21} A maioria dos fármacos é excretada em quantidade muito pequena no leite, o que permite a amamentação, com exceção do lítio (ver seção “Lactação” no Cap. 24).

O termo “meia-vida” de uma droga refere-se à quantidade de tempo consumida para que os processos de metabolismo e excreção reduzam a concentração plasmática de um determinado fármaco pela metade. Um fármaco administrado continuamente, em intervalos de tempo mais curtos do que sua meia-vida, alcança 97% de sua concentração plasmática de estado de equilíbrio (*steady state*) depois de cinco meias-vidas.

Para a quantificação de metabolismo e excreção de um dado psicofármaco, os parâmetros mais importantes a serem considerados são: o tempo de pico de concentração plasmática, o tempo de meia-vida, a intensidade do efeito de primeira passagem e a taxa de excreção.

INTERAÇÕES MEDICAMENTOSAS

Interações medicamentosas são situações em que, de algum modo, uma droga afeta a atividade de outra quando ambas são administradas em conjunto. Pacientes clinicamente doentes podem necessitar do uso simultâneo de diversos fármacos, com risco de desenvolvimento de interações medicamentosas potencialmente significativas.

As interações medicamentosas podem ser farmacodinâmicas ou farmacocinéticas, e ambas variam em seu potencial de causar danos aos pacientes. Interações farmacodinâmicas dizem respeito aos efeitos das drogas em suas atividades ligadas aos receptores, causando alterações bioquímicas aditivas ou sinérgicas (i.e., a ação resultante da combinação dos fármacos é maior que a esperada pela simples ou antagonistas pela simples adição). Pode também ocorrer um novo efeito que não aconteceria no caso de administração isolada de apenas um dos fármacos usados conjuntamente. Em todas essas condições, as interações podem provocar efeitos adversos tóxicos. Um exemplo comum ocorre quando benzodiazepínicos são combinados com álcool. Como ambos os agentes atuam em receptores inibitórios gabaérgicos, o uso combinado prolonga e agrava a sedação, podendo inclusive levar ao óbito por depressão respiratória.²²

As interações farmacocinéticas, por sua vez, alteram a absorção, a distribuição, o metabolismo ou a excreção do medicamento, bem como sua concentração nos tecidos. É mais provável que essas interações sejam clinicamente significativas quando o medicamento envolvido tem um índice terapêutico baixo ou metabólitos ativos. No uso combinado de ácido valproico e lamotrigina, por exemplo, a concentração sérica e a meia-vida desta última tendem a estar aumentadas, devido à menor metabolização hepática induzida pela ação do ácido valproico, que inibe sua glicuronidação.⁸

Alguns medicamentos são administrados na forma de pró-drogas. Apenas seus metabólitos primários, produzidos após a ação de enzimas hepáticas, têm atividades terapêuticas. Um exemplo é o tamoxifeno, droga usada no tratamento do câncer de mama, que é convertido em endoxifeno, seu metabólito ativo, pelas enzimas do complexo enzimático do citocromo P450 2D6. Drogas que inibem esse complexo, como a fluoxetina e a paroxetina, podem reduzir a ação do tamoxifeno, por inibirem sua metabolização para endoxifeno.

Entretanto, existem drogas que são potentes indutores hepáticos. A carbamazepina, por exemplo, é um indutor dos complexos enzimáticos dos citocromos P450 2D6 e 3A4, acelerando a metabolização de outras drogas que também dependem desses complexos. Deve-se dar particular atenção ao uso de contraceptivos orais, cujo efeito é reduzido quando combinados com a carbamazepina, podendo ocorrer gravidez indesejada. Além disso, a carbamazepina tem potencial teratogênico (ver seção “Gravidez”, no Cap. 24), com risco de malformações fetais caso a paciente engravide fazendo uso desse medicamento.

Existem fármacos cujo uso clínico foi bastante reduzido devido ao risco de potenciais interações. Entre os psicofármacos, o principal exemplo ocorreu com os IMAOs, que, a despeito de eficácia clínica, têm interações potencialmente graves com uma ampla gama de medicações, incluindo agentes simpatomiméticos, agentes dopaminérgicos e outros antidepressivos. Além disso, apresentam também interações dietéticas com alimentos contendo tiramina. Entre as

reações adversas, pode ocorrer síndrome serotoninérgica ou *delirium*, principalmente em idosos. O detalhamento dessas condições é feito no Capítulo 25.

A ocorrência de interações medicamentosas deve ser sempre suspeitada, mesmo quando ainda não houver sintomas clinicamente observáveis, pois várias delas podem ser de instalação insidiosa. No exemplo citado, sobre a lamotrigina e o ácido valproico, interações adversas podem ocorrer em até dois anos após o início do uso combinado das medicações.⁸ O Quadro 23.3 resume algumas das mais clássicas e perigosas interações medicamentosas conhecidas. Existem, porém, diversos aplicativos e *sites*, constantemente atualizados e de acesso gratuito (Quadro 23.4), que informam sobre possíveis interações. Recomendamos que sejam utilizados em todos os casos em que mais de uma droga for prescrita simultaneamente.

QUADRO 23.3

Algumas interações medicamentosas potencialmente perigosas que devem ser evitadas

Lítio	
Aminofilina/Teofilina	Xantinas podem reduzir a litemia em 20-30%, necessitando de possíveis aumentos na dose do lítio e monitoramento frequente.
Anti-inflamatórios não esteroidais (AINEs)	Grande risco de aumento nas concentrações do lítio, pela redução do fluxo sanguíneo renal e inibição de prostaglandinas. Maiores riscos são com indometacina, ibuprofeno, diclofenaco e piroxicam.
Diuréticos tiazídicos	Tiazídicos reduzem a depuração renal do lítio, aumentando sua concentração, com grande risco de intoxicação.
Inibidores da enzima conversora de angiotensina (IECAs)	Risco alto de intoxicação pelo lítio, particularmente em idosos.
Metildopa	Aumento do risco de toxicidade pelo lítio, mesmo em litemias normais.
Inibidores seletivos de recaptação da serotonina (ISRSs)	
AINEs	Aumento do risco de sangramento gastrointestinal por anti-inflamatórios, principalmente em idosos.
Antipsicóticos	A fluoxetina potencializa os riscos de efeitos extrapiramidais graves induzidos por antipsicóticos, além de a combinação poder induzir bradicardia e <i>delirium</i> . Evitar o uso de fluoxetina, paroxetina ou sertralina com clozapina.
Fluoxetina e varfarina	Risco de intoxicação varfarínica e aumento do risco de sangramentos.
Anticonvulsivantes	A lamotrigina pode aumentar o risco de toxicidade da sertralina, e esta pode aumentar as concentrações da primeira. A fluoxetina pode aumentar as concentrações da fenitoína e de outros anticonvulsivantes.
Tricíclicos	Fluoxetina, paroxetina e fluvoxamina, por inibirem o citocromo P450 2D6, aumentam a concentração de tricíclicos. Risco de síndrome serotoninérgica com diversas combinações de ISRSs e tricíclicos.
Antipsicóticos	
Álcool	Risco de sedação, <i>delirium</i> , hipotensão e depressão respiratória.
Anticonvulsivantes	Diversos antipsicóticos rebaixam o limiar convulsivo e podem antagonizar a ação de anticonvulsivantes. Barbitúricos, fenitoína e carbamazepina aceleram o metabolismo de diversos antipsicóticos e podem potencializar sedação.
Anti-histamínicos	Aumento no risco de arritmias.
Levodopa	Efeitos terapêuticos dos antipsicóticos são antagonizados pela levodopa, e vice-versa.
Lítio	Risco de <i>delirium</i> , particularmente em idosos. Possível neurotoxicidade, aumento de chance de efeitos extrapiramidais e cetoacidose diabética com clorpromazina, clozapina e risperidona.
Antidepressivos tricíclicos	
Álcool	Aumento de sedação e redução de limiar convulsivo.
Anticonvulsivantes	Barbitúricos e carbamazepina reduzem as concentrações séricas de tricíclicos. Tricíclicos podem baixar o limiar convulsivo. Imipramina pode aumentar a concentração sérica de fenitoína.
Cimetidina	Maior risco de efeitos anticolinérgicos com o aumento das concentrações de tricíclicos induzidas pela cimetidina.
Clonidina	Tricíclicos antagonizam os efeitos hipotensivos da clonidina.

Simpatomiméticos vasoconstritores

Risco aumentado de hipertensão e arritmias em indivíduos usando agentes contendo norepinefrina e fenilefrina.

Tramadol

Aumento no risco de convulsões.

Fonte: Com base em Bazire.⁸

QUADRO 23.4

Sites e aplicativos para celular

- Site <http://www.drugs.com> e aplicativo **Drugs.com Medication Guide**:²⁶ é gratuito e financiado por doações e anúncios no site e no software. O banco de dados é atualizado mensalmente, pela Wolters Kluwer Health e pela Cerner Multum, e trimestralmente, pela American Society of Health-System Pharmacists e pela Micromedex from Truven Health.
- Site <http://www.medscape.com> e aplicativo **Medscape**:²⁷ gratuito, com atualizações mensais. O site tem uma versão em português e é parte do WebMD Health Professional Network, que inclui a theHeart.org e o eMedicine.com.
- Site <http://www.epocrates.com> e aplicativo **Epocrates**:²⁸ há uma versão gratuita e outra paga (**Epocrates Plus**), sendo um produto do grupo Athenahealth.

Os sites e aplicativos, além de avaliarem interações medicamentosas, fornecem informações sobre efeitos adversos, posologias, condições clínicas nas diversas especialidades médicas, calculadoras, identificadores de medicamentos pela descrição da cor e forma e as respectivas bulas. O Quadro 23.4 lista três serviços que dispõem de sites na internet e de aplicativos, disponíveis para sistemas Android e iOS.

Evidências de eficácia e efetividade e segurança

Para que os psicofármacos possam ser utilizados na prática clínica, são necessários diversos estudos prévios, seguindo normas éticas, científicas e uma sequência de fases (Quadro 23.5). Estudos que pesquisam eficácia, efetividade e segurança de psicofármacos têm diversos graus possíveis de evidências (Quadro 23.6). No Quadro 23.7, encontram-se resumidos alguns dos princípios básicos para a prescrição racional de psicofármacos.

QUADRO 23.5

Fases de pesquisa em psicofarmacologia para avaliação de eficácia*, efetividade** e segurança

Fase pré-clínica (pesquisas em animais)

Obtenção de informações preliminares, como atividade farmacológica e segurança da nova molécula, até então apenas identificada em experimentos *in vitro* como tendo potencial terapêutico. Mais de 90% das substâncias estudadas são eliminadas ainda nesta fase.

Fase I

20 a 100 indivíduos saudáveis

Avaliação inicial em humanos, buscando informações preliminares sobre segurança e tolerância em voluntários saudáveis. São calculados a maior dose tolerável, a menor dose efetiva, a relação dose-efeito, a duração do efeito, os efeitos adversos e as interações com outras drogas ou álcool. O perfil farmacocinético é estabelecido, e, quando possível, também pode ser traçado um perfil farmacodinâmico.

Fase II

100 a 300 indivíduos acometidos

Estudos-piloto controlados em poucos pacientes. Busca-se demonstrar efetividade potencial da medicação, indicação de sua eficácia, confirmação da segurança, biodisponibilidade, bioequivalência de diferentes formulações e relações dose-resposta.

Fase III

5.000 a 10.000 indivíduos acometidos

Estudos em larga escala, por períodos maiores de tempo, em múltiplos centros internacionais, com diferentes populações de pacientes. Estabelecem-se o perfil terapêutico, indicações, dose e via de administração, contraindicações, efeitos adversos, fatores modificadores de efeito, interações clinicamente relevantes, medidas de precaução, vantagens terapêuticas em termos de farmacoeconomia e qualidade de vida. Registro e aprovação para uso comercial por autoridades sanitárias, se resultados amplamente favoráveis.

Fase IV

Milhares de pessoas

Ocorre após a aprovação para comercialização. Vigilância epidemiológica visando detectar eventos adversos pouco frequentes ou não esperados, estudos adicionais comparativos com produtos competidores e pesquisa de novas formulações (p. ex., mais palatáveis e com facilidade de ingestão).

* Eficácia: termo usado para indicar que um tratamento demonstrou benefícios terapêuticos quando testado em condições experimentais, em geral envolvendo amostras cuidadosamente selecionadas de pacientes.

** Efetividade: termo aplicado para tratamentos que mostraram benefícios em amostras clínicas habituais de pacientes, que são amplamente representativos da população passível de receber tais tratamentos.

Fonte: Agência Nacional de Vigilância Sanitária.^{29,30}

QUADRO 23.6

Graus de evidência por tipo de estudo*

Grau de evidência	Características do estudo
I	Fortes evidências a partir de, pelo menos, uma revisão sistemática de múltiplos ensaios clínicos randomizados e bem controlados.*
II	Forte evidência a partir de, pelo menos, um ensaio randomizado, devidamente concebido e controlado.
III	Evidência a partir de estudos bem desenhados sem randomização, com grupo único, “pré e pós”, coorte, séries temporais ou estudos combinados caso-controle.
IV	Evidência a partir de estudos não experimentais bem desenhados de mais de um centro ou grupo de pesquisa.
V	Opiniões de autoridades respeitadas, com base em evidências clínicas, estudos descritivos divulgações por comitês de especialistas.

* Em um estudo clínico randomizado, os sujeitos são alocados ao acaso, sem seu conhecimento ou do pesquisador, em dois grupos: o que receberá tratamento e o controle. Todos os sujeitos terão, rigorosamente, a mesma probabilidade de receber ou o fármaco experimental, ou aquele que corresponde ao controle (placebo ou um fármaco comparador).

Fonte: Gray.³¹

QUADRO 23.7

Princípios básicos da prescrição de psicofármacos

- Prescrever um psicofármaco não implica que intervenções psicológicas e/ou psicossociais não sejam indicadas.
- Envolver o paciente, familiares e cuidadores em uma colaboração relacionada ao uso da medicação, considerando as implicações psicológicas potencialmente envolvidas.
- Não prescrever antes de uma avaliação clínica detalhada. Documentar o alvo da ação do fármaco a ser prescrito e discutir os riscos e benefícios potenciais.
- Prevenção de gravidez e uso na gestação e/ou na amamentação. Sugere-se consultar livros e sites de interações. Não confiar apenas na memória.
- Iniciar o tratamento em doses baixas e com aumentos graduais, objetivando a mínima dose e o menor número de fármacos possível. Descontinuações também costumam ser graduais.
- Considerar custos, disponibilidade e continuidade do fornecimento quando da escolha do medicamento.
- Esclarecer a duração aproximada da farmacoterapia, relacionada às propriedades dos medicamentos e/ou à condição em tratamento.
- Informar possíveis efeitos colaterais e medidas de manejo, como redução de doses e explicação de que alguns efeitos são temporários.
- Controlar parâmetros clínicos e laboratoriais, incluindo circunferência abdominal, antes e durante o uso de um fármaco. Usar curvas padronizadas para crianças e adolescentes.
- Questionar sobre todas as substâncias usadas pelo paciente: outros medicamentos, cigarro, álcool e drogas ilícitas.
- Questionar o real uso da medicação em toda consulta. É comum que a adesão ao tratamento varie.
- Pesquisar comportamento suicida. Em caso de risco, limitar a quantidade de medicamentos prescritos e orientar a administração por membros da família ou amigos.
- Respeitar regulamentos sobre uso de medicações. Informar pacientes e cuidadores no caso de prescrições *off label**, bem como documentar as razões para tal decisão.

* Uso do termo *off label* ocorre quando os medicamentos são prescritos para uma indicação, dose ou faixa etária para a qual ainda não há evidências completas de eficácia e segurança, dadas pelas agências reguladoras. Isso não implica que o uso seja incorreto, e sim que a responsabilidade do médico pela prescrição não é amparada pelos órgãos de regulação.

Fonte: World Health Organization,³² Vitiello³³ e Agência Nacional de Vigilância Sanitária.³⁴

REFERÊNCIAS

1. Sadock BJ, Sadock VA, Ruiz P. Kaplan & Sadock's synopsis of psychiatry: behavioral sciences/clinical psychiatry. 11th ed. Philadelphia: Lippincott Williams and Wilkins; 2014.
2. Mathews M, Gratz S, Adetunji B, George V, Mathews M, Basil B. Antipsychotic-induced movement disorders: evaluation and treatment. *Psychiatry*. 2005;2(3):36-41.
3. Stahl S. Stahl's essential psychopharmacology: neuroscientific basis and practical applications. 4th ed. New York: Cambridge University; 2014.
4. Nussbaum A. Guia para o exame diagnóstico segundo o DSM-5. Porto Alegre: Artmed; 2015.
5. National Institute of Mental Health. Research Domain Criteria (RDoC) [Internet]. Bethesda: NIMH; c2016 [capturado em 12 jan. 2017]. Disponível em: <https://www.nimh.nih.gov/research-priorities/rdoc/index.shtml>.
6. Berney P. Dose-response relationship of recent antidepressants in the short-term treatment of depression. *Dialogues Clin Neurosci*. 2005;7(3):249-62.
7. Leonard BE, McCartan D, White J, King DJ. Methylphenidate: a review of its neuropharmacological, neuropsychological and adverse clinical effects. *Hum Psychopharmacol Clin Exp*. 2004;19(3):151-80.
8. Bazire S. Psychotropic drug directory. London: HealthComm; 2014.
9. Chugani DC, Muzik O, Juhász C, Janisse JJ, Ager J, Chugani HT. Postnatal maturation of human GABA: A receptors measured with positron emission tomography. *Ann Neurol*. 2001;49(5):618-26.
10. Hazell P, O'Connell D, Heathcote D, Robertson J, Henry D. Efficacy of tricyclic drugs in treating child and adolescent depression: a meta-analysis. *BMJ*. 1995;310(6984):897-901.
11. Greenhill LL, Swanson JM, Vitiello B, Davies M, Clevenger W, Wu M, et al. Impairment and deportment responses to different methylphenidate doses in children with ADHD: the MTA titration trial. *J Am Acad Child Adolesc Psychiatry*. 2001;40(2):180-7.
12. Correll CU. Multiple antipsychotic use associated with metabolic and cardiovascular adverse events in children and adolescents. *Evid Based Ment Health*. 2009;12(3):93.
13. King BH, Hollander E, Sikich L, McCracken JT, Scahill L, Bregman JD, et al. Lack of efficacy of citalopram in children with autism spectrum disorders and high levels of repetitive behavior: citalopram ineffective in children with autism. *Arch Gen Psychiatry*. 2009;66(6):583-90.
14. Won C. Food-drug interactions in psychiatry: what clinicians need to know. *Psychiatric Times*. 2014.
15. Andrade C. Sustained-release, extended-release, and other time-release formulations in neuropsychiatry. *J Clin Psychiatry*. 2015;76(8):e995-9.
16. Karhu D, Gossen ER, Mostert A, Cronjé T, Fradette C. Safety, tolerability, and pharmacokinetics of once-daily trazodone extended-release caplets in healthy subjects. *Int J Clin Pharmacol Ther*. 2011;49(12):730-43.

17. Taylor D, Paton C, Kapur S; South London and Maudsley NHS Trust. The maudsley prescribing guidelines in psychiatry. London: Wiley; 2015.
18. Taylor D. Psychopharmacology and adverse effects of antipsychotic long-acting injections: a review. *Br J Psychiatry Suppl.* 2009;52:S13-9.
19. Priebe S, Yeeles K, Bremner S, Lauber C, Eldridge S, Ashby D, et al. Effectiveness of financial incentives to improve adherence to maintenance treatment with antipsychotics: cluster randomised controlled trial. *BMJ.* 2013;347:f5847.
20. Schatzberg AF, Cole JO, DeBattista C. Manual of clinical psychopharmacology. 8th ed. Arlington: APA; 2015.
21. Rowland M, Tozer TN, Derendorf H, Hochhaus G. Clinical pharmacokinetics and pharmacodynamics concepts and applications. 4th ed. Baltimore: Lippincott Williams & Wilkins; 2011.
22. Sadock B, Sadock V, Sussman N. Kaplan & Sadock's pocket handbook of psychiatric drug treatment. 5th ed. Philadelphia: Lippincott Williams & Wilkins; 2011.
23. Kroon LA. Drug interactions with smoking. *Am J Health Syst Pharm.* 2007;64(18):1917-21.
24. Dos Santos Júnior A, Henriques TB, de Mello MP, Ferreira Neto AP, Paes LA, Della Torre OH, et al. Hyperprolactinemia in children and adolescents with use of risperidone: clinical and molecular genetics aspects. *J Child Adolesc Psychopharmacol.* 2015;25(10):738-48.
25. Dos Santos-Júnior A, Henriques TB, de Mello MP, Della Torre OH, Paes LA, Ferreira-Neto AP, et al. Pharmacogenetics of risperidone and cardiovascular risk in children and adolescents. *Int J Endocrinol.* 2016;2016:5872423.
26. Drugs.com [Internet]. Auckland: Drugs; c2017 [capturado em 13 jan. 2017]. Disponível em: <https://www.drugs.com/>.
27. Medscape.com [Internet]. California: Medscape; c2017 [capturado em 13 jan. 2017]. Disponível em: <http://www.medscape.com/>.
28. Epocrates.com [Internet]. Epocrates; c2016 [capturado em 13 jan. 2017]. Disponível em: <http://www.epocrates.com/>.
29. Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Pesquisa clínica [Internet]. Brasília: ANVISA; c2017 [capturado em 12 jan. 2017]. Disponível em: <http://www.anvisa.gov.br/medicamentos/pesquisa/def.htm>.
30. Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Quais são as fases da pesquisa clínica? [Internet]. Campinas: Universidade de Campinas; c2017. Disponível em: <http://www.fcm.unicamp.br/fcm/cpc-centro-de-pesquisa-clinica/pesquisa-clinica/quais-sao-fases-da-pesquisa-clinica>.
31. Gray J. Evidence-based healthcare. Edinburgh: Churchill Livingstone; 1997.
32. World Health Organization. Pharmacological treatment of mental disorders in primary health care. Geneva: WHO; 2009.
33. Vitiello B. Principles in using psychotropic medication in children and adolescents [Internet]. Baltimore: International Association for Child; Adolescent Psychiatry and Allied Professions; 2012 [capturado em 12 jan. 2017]. Disponível em: <http://iacapap.org/wp-content/uploads/A.7-PSYCHOPHARMACOLOGY-072012.pdf>.

34. Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Registro de medicamentos [Internet]. Brasília: ANVISA; c2017 [capturado em 12 jan. 2017]. Disponível em: http://www.anvisa.gov.br/medicamentos/registro/registro_offlabel.htm.



Psicofármacos: uso em situações clínicas especiais

Neury José Botega
Celso Garcia Junior
Sabrina Stefanello
Carlos Filinto da Silva Cais

Este capítulo aborda situações frequentes na prática clínica em que psicofármacos são prescritos a pessoas que se encontram em uma condição clínica especial, quer seja relacionada a uma doença não psiquiátrica, quer seja à gravidez e à amamentação. Deve-se levar em conta como a patologia de base afeta o metabolismo e os efeitos do psicofármaco, bem como o risco de interação medicamentosa. Devem ser consideradas, também, as complicações potenciais advindas do início, ou da continuidade, de um psicofármaco que, além das ações no sistema nervoso, também pode afetar outros sistemas de regulação corporal. Certas condições clínicas, como HIV/aids, gravidez e puerpério, são abordadas com mais detalhes em outros capítulos. As indicações aqui contidas são concisas e atualizadas até a data de elaboração desta edição. Recomendamos ao leitor sempre se atualizar quanto a indicações terapêuticas e interações medicamentosas em *sites* específicos aqui sugeridos.

Os autores deste capítulo esforçaram-se para atualizá-lo até o fechamento da presente edição. Considerando o crescente número de fármacos e de atualizações disponíveis, aconselha-se ao leitor sempre pesquisar as interações medicamentosas em *sites* e aplicativos.

ACIDENTE VASCULAR CEREBRAL (AVC)

Antipsicóticos

Em casos em que tenha ocorrido um acidente vascular cerebral, sugere-se evitar o uso de medicamentos antipsicóticos. Há maior risco de morte em idosos demenciados tratados com essa classe de medicamentos (ver seção “Idosos”). No entanto, as evidências não são tão claras quando se considera o AVC.¹ É mais seguro tentar outras formas de manejo antes de usar antipsicóticos e discutir os riscos com familiares e cuidadores. Mais informações podem ser encontradas no Capítulo 10, sobre interconsulta de pacientes idosos, e no Capítulo 13, sobre agitação psicomotora.

Antidepressivos

Não se identificou nenhum antidepressivo ou classe específica que seja superior no tratamento da depressão em pessoas que tenham sofrido AVC.² Assim, o que irá definir a escolha do medicamento mais apropriado será o perfil de sintomas do paciente, as doenças associadas, os medicamentos em uso e as potenciais interações medicamentosas.

Os inibidores da recaptação de serotonina estão entre os mais prescritos, mas também estão associados ao aumento da mortalidade e da ocorrência de AVC.³ Recentemente, tem-se observado um aumento no risco de microsangramentos cerebrais com o uso de antidepressivos, tanto inibidores seletivos da recaptação de serotonina (ISRSs) quanto inibidores seletivos da recaptação de serotonina e noradrenalina (ISRSNs).⁴ Com isso, vale reforçar a importância de considerar o tipo de AVC e os riscos associados caso a caso.

Ainda há carência de estudos para confirmar se a vortioxetina é eficaz e segura no tratamento da depressão associada à doença cerebrovascular, apesar de promissora em relação à melhora cognitiva.⁵

Ansiolíticos e hipnóticos

Após um AVC, quando houver prejuízo cognitivo associado, deve-se evitar o uso de benzodiazepínicos, especialmente os de meia-vida longa.⁶ Um estudo de revisão concluiu que buspirona e paroxetina reduziram sintomas de ansiedade após um AVC, tendo a primeira menos efeitos colaterais, o que sugere que o uso dessa medicação seja mais indicado nesses casos.⁷ O uso de zolpidem, em um estudo de caso-controle de base populacional, associou-se a maior risco de AVC; portanto, sugere-se evitar o uso desse medicamento.⁸

Estabilizadores do humor

Um estudo de coorte retrospectivo populacional identificou menor risco de AVC em pacientes com transtorno bipolar em uso de lítio quando comparados ao grupo que não usava essa

medicação, sendo considerada a droga de preferência nesses casos.⁹ Outros estudos demonstraram que a utilização de lamotrigina¹⁰ e valproato¹¹ no tratamento da labilidade emocional em pessoas que sofreram AVC teve bons resultados. Lítio, valproato de sódio e lamotrigina parecem exercer efeito protetor em diferentes modelos experimentais de AVC.¹²

Anticolinesterásicos e memantina

O uso de anticolinesterásicos ou antagonistas não competitivos do receptor de N-metil-D-aspartato (NMDA) em pessoas com demência vascular ou alteração cognitiva de origem vascular mostrou resultados conflitantes, porém com pequena melhora relatada para donepezila, memantina e galantamina.¹³ Portanto, tais medicamentos são considerados preferenciais.

Estimulantes e modafinil

Apesar de os dados sobre o uso de estimulantes serem conflitantes, eles já foram associados a aumento do risco para acidente isquêmico transitório, arritmia ventricular e morte súbita, o que sugere que a utilização desse tipo de medicamento deve ser evitada nesses casos.¹⁴ Prefere-se, então, o uso de modafinil, por ter apresentado bons resultados nos casos de fadiga após ocorrência de AVC no tronco cerebral ou no diencéfalo.¹⁵

ACNE

A isotretinoína é um retinoide sintético usado no tratamento da acne – doença dermatológica que acomete muitos adolescentes, causando-lhes considerável impacto psicológico. Desde seu lançamento, a droga vem sendo associada a efeitos colaterais psiquiátricos, como depressão, psicose e ideação suicida, mas nem sempre os resultados dos estudos são coincidentes.¹⁶

A preocupação com o potencial surgimento de sintomas psiquiátricos não deve impedir o tratamento, e sim justificar o monitoramento cuidadoso do paciente. Especial atenção deve ser dada a pacientes com antecedentes pessoais ou familiares de transtornos do humor.^{17,18}

Em pacientes que sofrem de acne ocasionada ou exacerbada pelo lítio, a introdução da isotretinoína pode desencadear crises afetivas. Não há recomendação ou restrição para nenhum outro psicofármaco em especial.

CÂNCER

Dado o impacto que o diagnóstico de câncer causa sobre pacientes e familiares, dificuldades de ajustamento e o surgimento de sintomas de depressão, ansiedade e *delirium* ocorrem em até um terço dos pacientes. Além disso, depressão e fadiga encontram-se frequentemente associadas ao tratamento quimio e radioterápico.¹⁹

Alguns medicamentos utilizados em oncologia causam transtornos psiquiátricos, notadamente depressão e *delirium*, devido à toxicidade no sistema nervoso central. São exemplos desses medicamentos 5-fluorouracil, ifosfamida, asparaginase, clorambucil, citarabina, metotrexato, bortezomibe, interferon, interleucina, tamoxifeno, tretinoína, vincristina, vimblastina, prednisona e procarbazina. Ademais, vários quimioterápicos aumentam o intervalo QTc, o que exige cautela durante o uso de psicotrópicos, como antipsicóticos, antidepressivos tricíclicos (ADTs) e alguns ISRSs, que também causam esse efeito.^{20,21}

Alguns psicofármacos são bastante utilizados em oncologia, como ADTs e ISRSNs no controle da dor; olanzapina e mirtazapina, em caso de náusea e vômitos induzidos pela quimioterapia; e venlafaxina, em caso de ondas de calor provocadas pelo câncer de mama.^{19, 22-24}

Antipsicóticos

É prudente evitar, principalmente em casos de câncer de mama, antipsicóticos que ocasionem hiperprolactinemia (notadamente risperidona, amisulprida e paliperidona). O uso de risperidona foi associado a aumento da incidência de tumores de hipófise.²⁵ Se o uso de antipsicóticos for necessário, deve-se aferir trimestralmente os níveis de prolactina.

Antipsicóticos que retardam a condução do estímulo cardíaco devem ser evitados, pois vários quimioterápicos aumentam o intervalo QTc. Haloperidol e olanzapina têm sido os mais usados. Deve-se monitorar o eletrocardiograma (ECG) caso seja necessário usar antipsicóticos.

Antidepressivos

Muitos quimioterápicos precisam ser ativados pelo sistema do citocromo P450 para que tenham efeito clínico (Tab. 24.1). O tamoxifeno, por exemplo, é metabolizado em duas fases e requer a ação das enzimas 2D6 e 3A4 para a produção de seu metabólito ativo, o endoxifeno. Esse processo pode ser prejudicado quando paroxetina, fluoxetina, duloxetina, bupropiona e doses mais elevadas de sertralina (> 150 mg) forem utilizadas, pois essas drogas inibem a enzima 2D6. Sugre-se dar preferência à utilização de escitalopram, citalopram, venlafaxina e mirtazapina.

Tabela 24.1

Quimioterápicos cujos metabólitos precisam ser ativados via sistema do citocromo P450

Pró-droga	Enzimas ativadoras do metabólito ativo
Ciclofosfamida	2B6
Dacarbazina	1A2

Ifosfamida	3A4
Tamoxifeno	2D6, 3A4
Trofesfamida	3A4

Fonte: Com base em Ferrando e Owen.²⁰

Muitos quimioterápicos são metabolizados pela enzima 3A4. Por isso, os inibidores dessa enzima, como a fluoxetina e a fluvoxamina, devem ser evitados.

O hipérico, por induzir essa enzima, pode reduzir as doses adequadas de alguns quimioterápicos, como o irinotecan.^{22,26}

A mirtazapina pode melhorar sintomas relacionados ao câncer e ao tratamento quimioterápico, tais como caquexia, náusea, inapetência e insônia. A bupropiona é útil quando há fadiga e retardo cognitivo e psicomotor.¹⁹

Os ADTs, bem como o escitalopram e o citalopram em doses altas, prolongam o intervalo QTc, assim como vários quimioterápicos (ver seção “Problemas cardiopulmonares”). Antidepressivos que podem precipitar uma reação serotoninérgica não devem ser utilizados em conjunto com procarbazine, que também tem tal propriedade, via inibição da monoaminoxidase (MAO).

Ansiolíticos e hipnóticos

O lorazepam é preferível devido a sua farmacocinética (ver seção “Insuficiência hepática”).

Estabilizadores do humor

- Preferível: lítio.
- Evitar: carbamazepina.

O valproato (via inibição da uridina difosfato-glucuronosiltransferase) reduz o metabolismo do metabólito ativo do irinotecan, o que ocasiona toxicidade hepática.²⁷ Além disso, a carbamazepina deve ser evitada, pois induz as enzimas 3A4 e 2B6 e diminui o transporte de folato (necessário para a ação do tamoxifeno). Portanto, sugere-se dar preferência ao uso do lítio, porém, sua dose deverá ser reduzida em pacientes graves.¹⁹

Outros

O metilfenidato, em doses de 10 a 50 mg/dia, foi utilizado em estudos abertos realizados em casos de câncer avançado, com bons resultados no tratamento da depressão e da fadiga, melhorando, também, o desempenho cognitivo. O metilfenidato potencializa a analgesia e diminui a sonolência produzidas pelos opioides. O início de ação dá-se em 2 a 5 dias. O modafanil (200-400 mg/dia), ainda que com menos documentação científica, também tem sido usado nessas condições clínicas.^{19,28}

PROBLEMAS CARDIOPULMONARES

Para a maioria dos pacientes, problemas cardíacos não causam alterações na absorção, distribuição, metabolismo e eliminação dos medicamentos. Entretanto, existem algumas exceções (Quadro 24.1). As doenças respiratórias também não costumam alterar o metabolismo dos medicamentos, exceto fibrose cística e tabagismo.

QUADRO 24.1

Mudanças farmacocinéticas na doença cardíaca

Alteração	Fisiologia	Farmacocinética	Impacto
Insuficiência cardíaca direita	Estase hepática, edema de parede intestinal	Diminuição da absorção	Indeterminado
Cirrose hepática secundária a insuficiência cardíaca congestiva	Redução na albumina, ascite, aumento enzima alfa 1 glicoproteína ácida	Aumento ou diminuição dos níveis de droga livre	Indeterminado
Insuficiência cardíaca esquerda	Diminuição do fluxo sanguíneo na artéria hepática, redução da fase 1 do metabolismo hepático Redução do fluxo sanguíneo, diminuição da taxa de filtração glomerular	Redução na eliminação de drogas semelhantes Diminuição da eliminação de moléculas hidrossolúveis	Importante para drogas com baixo índice terapêutico e alta excreção hepática Risco de toxicidade por lítio

Fonte: Com base em Shapiro.²⁹

Na fibrose cística, o metabolismo oxidativo hepático aumenta, mas somente para os substratos do citocromo 1A2 e 2C8.³⁰ O tabagismo, independentemente do desenvolvimento de doença pulmonar crônica, induz os citocromos 1A2, 2B6 e 2D6, o que acarreta aumento do metabolismo dos substratos dessa enzima, tais como clozapina, olanzapina, duloxetine, teofilina, benzodiazepínicos, zolpidem, fluvoxamina, mirtazapina e antidepressivos tricíclicos.³¹

Alguns medicamentos comumente utilizados no tratamento de doenças cardiovasculares e respiratórias podem causar efeitos neuropsiquiátricos (Quadro 24.2).

QUADRO 24.2

Efeitos colaterais neuropsiquiátricos das medicações mais usadas em doenças cardiovasculares e respiratórias

Medicações	Efeitos colaterais
Doenças cardiovasculares	
■ Bloqueadores alfa-adrenérgicos (p. ex., prazosina, doxazosina)	Depressão, disfunção sexual
■ Amiodarona	Alterações do humor por disfunção da tireoide
■ Inibidores da enzima conversora de angiotensina (p. ex., captopril, enalapril)	Elevação do humor, depressão (raro)
■ Agentes antiarrítmicos (p. ex., verapamil, adenosina)	Alucinações, confusão, <i>delirium</i>
■ Bloqueadores beta-adrenérgicos (p. ex., atenolol, propranolol)	Fadiga, disfunção sexual
■ Digoxina	Alucinações visuais, <i>delirium</i> , depressão
■ Diuréticos (p. ex., hidroclorotiazida, furosemida)	Anorexia, fraqueza, apatia
Doenças respiratórias	

■ Atropina	Paranoia, alucinações visuais, táteis e alucinatórias, perda de memória, <i>delirium</i>
■ Beta-agonistas (p. ex., salmeterol, albuterol)	Tremores, ansiedade, insônia, palpitações
■ Aminofilina e teofilina	Ansiedade, insônia, tremores, inquietação, abstinência, hiperatividade, psicose, <i>delirium</i> , mutismo
■ Modafinil	Ansiedade, depressão
■ Corticosteroides orais (p. ex., prednisona, dexametasona)	Depressão, mania, labilidade, ansiedade, insônia, psicose, alucinação, paranoia, mudanças na personalidade
■ Inibidor de leucotrienos (montelucaste)	Fadiga, astenia, ideação suicida
■ Alfa e beta-agonistas mistos (p. ex., epinefrina, fenilefrina, fenilpropanolamina)	Ansiedade, tremor, psicose, alucinações, insônia, inquietação, depressão, agressividade

Antipsicóticos

- Preferíveis: haloperidol, aripiprazol.
- Evitar: olanzapina, quetiapina e clozapina.

Todos os antipsicóticos podem causar prolongamento do intervalo QT, sendo que o QTc acima de 440 msec está associado a taquicardia ventricular polimórfica persistente (*torsades de pointes*), que pode evoluir para fibrilação ventricular. Faltam estudos que estabeleçam quais as melhores opções com menor risco de arritmia cardíaca e morte súbita.³²

O aripiprazol é uma boa escolha para pessoas com problemas cardíacos e apneia do sono obstrutiva devido ao menor risco de problemas metabólicos e de prolongamento do intervalo QRS. No entanto, esse fármaco pode causar ansiedade e acatisia. Portanto, o haloperidol, mesmo com os riscos conhecidos de prolongamento do intervalo QT, é uma medicação muito utilizada, com pouca cardiotoxicidade.³³

Deve-se evitar o uso de olanzapina, quetiapina e clozapina em pessoas com doença coronariana e apneia do sono obstrutiva devido à síndrome metabólica (ver “Diabetes”).

Antidepressivos

A inibição do citocromo 2D6 (p. ex., por fluoxetina e paroxetina) pode levar a interações medicamentosas, aumentando níveis de digoxina, betabloqueadores, etc. É necessário, também, reavaliar a anticoagulação ao utilizar ISRSs e, em menor grau, ISRSNs (ver “Cirurgia”).

A Food and Drug Administration (FDA), agência regulatória dos Estados Unidos, emitiu um alerta para o risco de aumento do intervalo QT com o uso de citalopram em doses superiores a 40 mg/dia (20 mg/dia para idosos ou pacientes com insuficiência hepática). As agências regulatórias do Canadá e do Reino Unido estendem esse cuidado para o S-isômero dessa droga, o escitalopram, que não deve ultrapassar a dose de 20 mg/dia em adultos e 10 mg/dia em idosos.³⁴

Venlafaxina, desvenlafaxina, duloxetina e bupropiona podem precipitar arritmias e aumentar a pressão arterial. Já os ADTs provocam hipotensão postural. Estes, apesar da eficácia no

tratamento da depressão, associam-se a maior mortalidade em pessoas com doença cardíaca isquêmica. É preferível usar sertralina e evitar tricíclicos.

Os ADTs podem ser benéficos em pacientes com asma e secreção copiosa, mas podem agravar o quadro daqueles com rolhas de muco; portanto, devem ser evitados na fibrose cística. Se necessário, a nortriptilina é eficaz e segura em pacientes com doença pulmonar obstrutiva crônica. Há maior risco de sangramento com ISRSs e ISRSNs.³⁵

Ansiolíticos e hipnóticos

A buspirona deve ser o ansiolítico de primeira escolha em pessoas com problemas pulmonares e ansiedade crônica, por não ser um benzodiazepínico, pois essa classe de medicamentos deve ser evitada nesses casos. No entanto, zolpidem e zopiclona são seguros em pacientes com apneia obstrutiva grave.³⁶

Lorazepam e oxazepam não passam pela Fase 1 do metabolismo hepático, portanto são pouco afetados no caso de alteração metabólica por insuficiência cardíaca. Agentes com meia-vida longa e com metabólitos ativos devem ser usados com cuidado e em doses mais baixas.³⁷

Estabilizadores do humor

O lítio é excretado basicamente pelos rins, além de interagir com diuréticos. Adicionalmente, acetazolamida e diuréticos osmóticos aumentam o *clearance* do lítio e diminuem seus níveis séricos. No entanto, diuréticos tiazídicos, inibidores da enzima conversora de angiotensina e bloqueadores de receptores de angiotensina II diminuem o *clearance* do lítio. O lítio já foi testado na fibrose cística e não teve impacto na função pulmonar,³⁸ mas pode causar disfunção do nó sinusal.³⁷

A carbamazepina está associada a arritmia cardíaca e a hiponatremia, especialmente em mulheres idosas. O ácido valproico não tem efeito cardiovascular, mas pode causar trombocitopenia, que pode ser importante em pacientes que usam anticoagulantes ou antiagregantes plaquetários.³⁷

Estimulantes e modafinil

O uso de estimulantes é contraindicado a pacientes com anormalidades cardíacas estruturais, miocardiopatia, doença coronariana e alterações graves no ritmo cardíaco. Um estudo relatou o uso de atomoxetina associado a prolongamento do intervalo QT e miocardiopatia.³⁹ Entretanto, o uso de modafinil pareceu promissor em pessoas com doença pulmonar obstrutiva crônica e hipercapnia,⁴⁰ bem como na sonolência diurna em pacientes com apneia do sono.⁴¹

Outros

Naltrexona e acamprosato não apresentam efeitos cardíacos descritos em estudos.

A vareniclina tem sido associada a eventos cardiovasculares e a desregulação na pressão arterial, causando vasoespasmo ou hipotensão.⁴²

O topiramato pode ser usado, mas interage com hidroclorotiazida e digoxina.

Colinesterásicos devem ser usados com cautela em pessoas com pneumopatias, porque aumentam a acetilcolina e podem causar broncoconstrição; portanto, o mais seguro seria a memantina. Existe relato de caso de bloqueio atrioventricular total com o uso de rivastigmina.⁴³

Os inibidores da 5-fosfodiesterase (sildenafil e tadalafina), usados na disfunção erétil, são contraindicados a pacientes que usam medicamentos à base de nitratos.

CIRURGIA

O período de cirurgia, bem como o de permanência em unidade de tratamento intensivo (UTI), pode envolver o acometimento de múltiplos órgãos e de sistemas de regulação corporal, rápidas mudanças no estado geral e limitações na via de administração, bem como o emprego de vários medicamentos. No pós-cirúrgico, podem ocorrer *delirium*, estresse pós-traumático e dor.⁴⁴⁻⁴⁶

Interromper ou não a medicação?

A decisão de suspender ou não um psicofármaco antes de uma cirurgia deve ponderar a influência de vários fatores. A manutenção da medicação rotineira implica, potencialmente, interações medicamentosas, interferências na regulação hemodinâmica e complicações pós-cirúrgicas (como sedação excessiva, íleo paralítico). A interrupção eleva o risco de perda do efeito terapêutico, exacerba sintomas por efeito-rebote, provoca reação de abstinência e de descontinuação, recaída e recorrência. Deve-se ponderar, também, as comorbidades de doenças somáticas, a extensão da cirurgia e o tipo de anestesia.⁴⁷ De modo geral, a interrupção do uso de lítio, clozapina, IMAOs e ADTs e a manutenção de ISRSs devem ser consideradas, e benzodiazepínicos devem ser mantidos.

A Tabela 24.2 agrupa as orientações de um consenso de especialistas que recomenda a parada de lítio, ADTs, inibidores da monoaminoxidase (IMAOs) e clozapina. Pacientes que utilizam esses medicamentos têm maior risco de complicações e são classificados como ASA 3 (Quadro 24.3). Sob o ponto de vista dos riscos físicos, eles deveriam parar de tomá-los. Só não precisam ser interrompidos em casos de pequenas cirurgias, com anestesia local. No entanto, considerando os riscos psiquiátricos quando da interrupção do lítio e da clozapina, a decisão deve ser ponderada.

Tabela 24.2

Características de psicofármacos a serem consideradas em situações de cirurgia eletiva

	Lítio	IMAOs	Tricíclicos	ISRSs	Antipsicóticos	Clozapina
Farmacocinética	$T_{1/2}$ = 36 h. Excreção renal. Clearance diminui na hiponatremia e na desidratação.	Pelo menos duas semanas para normalizar níveis de MAO.	$T_{1/2}$ variável de 12 h a 3 dias.	$T_{1/2}$ = 24-36 h (fluoxetina: 3-5 dias). Metabólitos da sertralina: 3-5 dias; da fluoxetina: 7-15 dias.	$T_{1/2}$ variável, até duas semanas na forma depot.	$T_{1/2}$ variável
Efeitos importantes	Pequena janela terapêutica. Risco de toxicidade. Bradycardia.	Hipotensão	Bloqueio de receptores, histamina, α -1 e acetilcolina. Arritmias cardíacas, íleo paralítico, retenção urinária, glaucoma, <i>delirium</i> .	Efeitos gastrintestinais, anorexia, cefaleia, insônia, agitação, sonolência. Hiponatremia possível.	Bloqueio de receptores de dopamina, histamina, α -1 e acetilcolina. Sintomas extrapiramidais (raros com atípicos).	Risco de agranulocitose e de hipertermia. Afeta condução cardíaca.

					Alteração da condução cardíaca. Risco de síndrome neuroléptica maligna (rara com atípicos).	
Interações importantes	Risco de toxicidade com AINEs, metronidazol, diuréticos tiazídicos e IECAs.	Crise hipertensiva com simpatomiméticos. Petidina, pentazocina e dextrometorfano: reação serotoninérgica. Com morfina, relato de parada cardiorrespiratória.	Hipertensão com simpatomiméticos. Convulsão com eflurene. <i>Delirium</i> com drogas anticolinérgicas.	Com AINEs, AAS e varfarina, pode ocorrer sangramento intestinal. Com outras drogas metabolizadas pelo citocromo P450, como petidina, pentazocina e fentanil: síndrome serotoninérgica. Evitar opioides.	Hipotensão com simpatomiméticos. Convulsão com desflurano. Potencialização de analgésicos narcóticos.	Relatos de arritmias cardíacas e de hipotensão grave.
Reação de descontinuação	Não	Sim	Sim	Sim	Não	Não
Necessidade de interrupção	Sim	Sim	Sim, em pacientes com ASA > 2, duas semanas antes da cirurgia.	Geralmente não	Não, mas monitorar ECG.	Sim

AAS, ácido acetilsalicílico; AINEs, anti-inflamatórios não esteroidais; ECG, eletrocardiograma; IECAs, inibidores da enzima conversora de angiotensina; IMAOs, inibidores da monoaminooxidase; ISRSs, inibidores seletivos da recaptação de serotonina; T_{1/2}, meia-vida plasmática.

Classificação da American Society of Anesthesiologists (ASA, 1978). ASA 1, paciente saudável; ASA 2, doença sistêmica moderada sem limitação das funções vitais; ASA 3, doença sistêmica grave com funções vitais comprometidas; ASA 4, doença sistêmica grave com ameaça à vida; ASA 5, paciente moribundo, morte esperada nas próximas 24h com ou sem intervenção cirúrgica.

Fonte: Com base em Huyse e colaboradores.⁴⁷

QUADRO 24.3

Classificação de risco anestésico da American Society of Anesthesiologists

- ASA 1: Paciente saudável
- ASA 2: Doença sistêmica leve
- ASA 3: Doença sistêmica grave com limitações funcionais
- ASA 4: Doença sistêmica grave com ameaça constante à vida
- ASA 5: Estado muito grave, pouco provável a sobrevivência em 24 horas

Fonte: Com base em American Society of Anesthesiologists.⁴⁸

No caso de haver variação hemodinâmica e hidreletrolítica, pode ocorrer intoxicação por lítio. Considerando sua meia-vida de 24 a 36 horas, a interrupção deve ocorrer 72 horas antes da cirurgia. Potencialmente, o lítio pode aumentar o efeito de bloqueadores musculares. Há relatos de psicose de rebote, em caso de cessação abrupta do lítio. Após a cirurgia, e se o paciente estiver estável, deve-se reinstituir a dose habitual.^[NT]

O risco da clozapina relaciona-se a interações medicamentosas que causam repercussões hemodinâmicas. A retirada dessa droga envolve risco de recaída e de menor resposta ao retomar o uso da medicação, o que deve ser levado em conta.

Os ADTs e IMAOs provocam efeitos cardíacos e interagem com anestésicos que regulam o sistema cardiovascular.

Os riscos e benefícios do uso de ISRSs em pacientes que serão submetidos a cirurgia devem ser ponderados caso a caso. A medicação pode ser mantida em pacientes que se encontram física e mentalmente estáveis (ASA 1). O risco, nesse caso, relaciona-se a discreto aumento de sangramento e a reações serotoninérgicas. Estas últimas podem ser minoradas com o uso de anestesia e analgesia com drogas não serotoninérgicas.^{35,47}

Quando o paciente se encontra estável em termos psiquiátricos e há alto risco de sangramento devido a cirurgia, o ISRS pode ser reduzido e retirado duas semanas antes da cirurgia. Ainda assim, poderá haver sintomas da síndrome de descontinuação (ver Cap. 25). Em casos de cirurgias de grande porte e eletivas, pode-se considerar a mudança de um ISRS para bupropiona ou mirtazapina.⁵⁰

Antipsicóticos típicos podem ser mantidos, embora haja o potencial de aumento da sedação. No caso de uso de antipsicóticos, devem ser feitos ECG para monitorar o intervalo QTc.

Os anticolinesterásicos aumentam o efeito da succinilcolina e de outros bloqueadores da despolarização muscular.⁵¹

Há condições em que o paciente não poderá, após a cirurgia, ingerir medicamentos. Nesses casos, aconselha-se manter o medicamento até a cirurgia ou, se possível, substituí-lo por outro similar, que possa ser dado por outra via. Lamentavelmente, contamos com poucas opções em situações em que um psicofármaco não pode ser administrado por via oral.^[NT] Em nosso país, mirtazapina, asenapina e olanzapina têm formulações orodispersíveis.

É importante lembrar que medicações usadas em cirurgia e UTI podem causar sintomas psiquiátricos (Quadro 24.4). As principais interações dessas drogas com os psicofármacos encontram-se no Quadro 24.5.

QUADRO 24.4

Efeitos psicopatológicos de alguns medicamentos utilizados em cirurgia e UTI

Medicamento	Efeitos psicopatológicos
Anestésicos inalatórios Desflurano, enflurano, halotano, isoflurano, metoxiflurano, sevoflurano	Hipertermia maligna: <i>delirium</i> , instabilidade autonômica, rigidez muscular, tremor
Bloqueadores musculares - Succinilcolina - Óxido nitroso	Hipertermia maligna Psicose, declínio cognitivo
Simpatomiméticos Dobutamina, dopamina, epinefrina, isoproterenol, noradrenalina	Medo, ansiedade, irritação, inquietude, tremor, insônia, confusão, mania, psicose
Vasodilatadores	

■ Anrinona, isossorbida, milrinona, nesiritide, nitroglicerina, nitroprussiato	Aumento da pressão intracraniana, síncope
Indutores da anestesia	
■ Etomidato, midazolam, propofol	Sedação excessiva (especialmente com sedativos e opioides)

Fonte: Com base em Ferrando e colaboradores.⁵²

QUADRO 24.5

Principais interações medicamentosas de drogas utilizadas em cirurgia e UTI com psicofármacos

Medicamento	Efeito
Anestésicos inalatórios	
■ Desflurano, enflurano, halotano, isoflurano, metoxiflurano, sevoflurano	Maior sedação com ADTs e antipsicóticos com ação sedativa e anti-histaminérgica Maior hipotensão com drogas que bloqueiam receptores alfa-1 (ADTs, IMAOs, antipsicóticos atípicos) Aritmias com drogas com efeito simpatomimético (ISRSNs, ADTs, psicoestimulantes)
Bloqueadores musculares	
■ Succinilcolina	Maior bloqueio muscular com anticolinesterásicos Diminuição do bloqueio com drogas com efeitos anticolinérgicos (ADTs, antipsicóticos, biperideno)
■ Pancurônio	Anticolinesterásicos reverterem o efeito nicotínico do bloqueio muscular Lítio e carbamazepina potencializam bloqueio
Óxido nitroso	Sedativo-hipnóticos podem diminuir o efeito anestésico
Simpatomiméticos	
■ Dobutamina, epinefrina, noradrenalina	dopamina, isoproterenol, Com IMAOs: crise hipertensiva Maior hipotensão com drogas que bloqueiam alfa-1 (ADTs, antipsicóticos típicos e atípicos) Hipertensão e hiperativação com drogas de ação dopaminérgica e adrenérgica (ADTs, bupropiona, ISRSNs, metilfenidato, etc.) Dobutamina causa hipocalemia e aumenta risco de drogas que aumentam o intervalo QT (ADTs, antipsicóticos típicos e atípicos, lítio)
Vasodilatadores	
■ Anrinona, isossorbida, milrinona, nesiritide, nitroglicerina, nitroprussiato	Maior hipotensão com drogas que bloqueiam receptores alfa-1 (ADTs, IMAOs, antipsicóticos atípicos)
Indutores da anestesia	
■ Etomidato, midazolam, propofol	Maior sedação com ADTs e antipsicóticos com ação sedativa e anti-histaminérgica

ADTs, antidepressivos tricíclicos; IMAOs, inibidores da monoaminoxidase; ISRSNs, inibidores seletivos da recaptação de serotonina e noradrenalina.

Fonte: Ferrando e colaboradores⁵²e Hachenberg e Schneemilch.⁵³

DIABETES

A síndrome metabólica tem como componentes centrais obesidade, resistência insulínica, dislipidemia e hipertensão (Tab. 24.3). As mudanças metabólicas são proporcionais ao ganho de peso, que está associado ao bloqueio histamínico e serotoninérgico (receptores 2C), bem como ao aumento nos níveis de insulina e leptina. Antipsicóticos típicos e atípicos, ADTs, ácido valproico e lítio têm sido associados à síndrome metabólica.⁵² A Tabela 24.3 contém a definição global da síndrome metabólica pelo consenso do Grupo de Trabalho em Epidemiologia e Prevenção da Federação Internacional de Diabetes (FID), do Instituto Nacional de Coração, Pulmão e Sangue dos Estados Unidos, da Associação Americana de Coração, da Federação Mundial de Coração, da Sociedade Internacional de Aterosclerose e da Associação Internacional para o Estudo da Obesidade. É necessário haver três dos cinco critérios apresentados.^{54,55}

Tabela 24.3

Definição de síndrome metabólica

Obesidade central	Circunferência abdominal ≥ 90 cm para homens e ≥ 80 cm para mulheres*
Aumento de triglicerídeos	≥ 150 mg/dL (1,7 mmol/L) ou tratamento específico para triglicerídeos aumentados
Redução do colesterol HDL	< 40 mg/dL para homens (1,03 mmol/L) < 50 mg/dL para mulheres (1,29 mmol/L) ou tratamento específico para dislipidemia
Aumento da pressão arterial	Sistólica ≥ 130 mmHg ou Diastólica ≥ 85 mmHg ou tratamento para hipertensão arterial sistêmica
Aumento da glicemia de jejum	Glicemia ≥ 100 mg/dL (5,6 mmol/L)** ou tratamento com hipoglicemiantes

* Valores mais usados e estudados para a população da América Latina.

** Se glicemia ≥ 100 mg/dL (5,6 mmol/L), teste de tolerância à glicose é fortemente recomendado, mas não é necessário para definir a presença da síndrome metabólica.

Fonte: López-Jaramillo e colaboradores⁵⁴ e Alberti e colaboradores.⁵⁵

Antipsicóticos

O uso de antipsicóticos, particularmente olanzapina, está associado a aumento do risco de diabetes tipo 2. Além da ziprasidona e do aripiprazol, que são os fármacos de preferência, o haloperidol é alternativa relativamente segura no diabetes. A lurasidona também parece ter menor influência no ganho de peso.^{56,57}

Antidepressivos

Recomenda-se cuidado com o uso de antidepressivos que contribuem para o ganho de peso.⁵⁸ Os ISRSs são preferidos em pacientes com diabetes devido ao seu efeito no metabolismo da glicose, assim como a duloxetine e a venlafaxina. É preciso controlar a glicemia, especialmente no início do tratamento, pois alguns efeitos colaterais, como tremor, náuseas, sudorese e ansiedade, podem

ser confundidos com hipoglicemia. Além disso, deve-se evitar o uso de IMAOs, ADTs, mirtazapina e paroxetina.

Para o tratamento da dor neuropática, recomendam-se os ISRSNs (duloxetina e venlafaxina), anticonvulsivantes (gabapentina e pregabalina) e antidepressivos tricíclicos.⁵⁹ Considerando-se justamente o risco de ganho de peso, é mais aconselhável o uso da primeira opção.

Ansiolíticos e hipnóticos

Não há restrição quanto ao uso de benzodiazepínicos ou da pregabalina.

Estabilizadores do humor

A princípio, todos podem contribuir para o ganho de peso. O valproato pode causar falso-positivo em testes de urina para diabetes.

Outros

Não existe contraindicação ao uso de modafinil, estimulantes ou anticolinesterásicos relacionada ao diabetes.

EPILEPSIA

Antipsicóticos

A clozapina e a clorpromazina diminuem o limiar convulsivante à medida que suas doses são aumentadas, portanto, seu uso deve ser evitado. As concentrações de todos os antipsicóticos diminuem com o uso concomitante da carbamazepina. A oxcarbazepina não costuma ter interação clinicamente significativa com antipsicóticos. Risperidona e quetiapina são os que menos interferem no limiar epileptogênico.⁶⁰

Antidepressivos

A bupropiona é mais arriscada, por diminuir o limiar convulsivante, notadamente em doses acima de 450 mg e nas formulações de liberação imediata; portanto, deve ser evitada.

Alguns ISRSs são inibidores de enzimas do citocromo P450 e requerem cuidado quanto a potenciais interações com antiepiléticos.^{60,61} Além disso, maprotilina, clomipramina e amitriptilina devem ser evitadas.

Fenitoína, carbamazepina e fenobarbital são indutores das enzimas hepáticas, acelerando o metabolismo da maioria dos antidepressivos. Topiramato e oxcarbazepina têm menor efeito indutor dessas enzimas. Com lamotrigina e gabapentina, tal efeito não é observado.

Ansiolíticos e hipnóticos

Tendo em vista que os benzodiazepínicos são usados agudamente, de forma intermitente ou como coadjuvantes no tratamento de epilepsia, não existe restrição quanto ao seu uso relacionado à epilepsia. A pregabalina é outra boa opção.⁶²

Estabilizadores do humor

A carbamazepina, além de estabilizador do humor, é um anticonvulsivante de primeira linha, equipotente ao fenobarbital e à fenitoína, sendo um dos medicamentos mais indicados além do ácido valproico.⁶³ O risco pró-convulsivante do lítio está relacionado a níveis tóxicos. É importante lembrar alguns efeitos adversos resultantes da associação de certos anticonvulsivantes com lítio: a carbamazepina aumenta o risco de toxicidade por lítio; o ácido valproico aumenta o risco de tremores, sedação e ganho de peso; e o topiramato causa diminuição do *clearance* de lítio, levando à toxicidade por essa substância. Em relação aos outros anticonvulsivantes, especialmente lamotrigina, as combinações com lítio são bem toleradas.⁶⁰

Outros

Existem poucos estudos com anfetaminas e atomoxetina. O uso de metilfenidato ou modafinil parece não piorar a frequência das crises epiléticas, mas requer cuidado.^{60,61,64} A memantina parece ser bem tolerada em pacientes com epilepsia recebendo anticonvulsivantes.⁶⁵ Poucos estudos com donepezila e galantamina não indicaram eficácia e sugeriram um possível aumento das crises.⁶⁶

GLAUCOMA

Após uma extensa revisão da literatura, Richa e Yazbek⁶⁷ afirmam que todos os psicofármacos podem, ainda que raramente, causar efeitos adversos oculares, desde a pálpebra até a retina. O Quadro 24.6 relaciona alguns deles.

QUADRO 24.6

Possíveis efeitos adversos oftalmológicos secundários aos psicofármacos

Psicofármaco	Efeito colateral oftalmológico
ADTs	Xerostomia, dificuldade na acomodação e glaucoma de ângulo fechado
Carbamazepina	Nistagmo, crise oculógira e oftalmoplegia
Clorpromazina	Depósitos pigmentares no cristalino e na córnea, ceratite epitelial, edema de córnea e retinopatia pigmentar
Diazepam	Glaucoma de ângulo fechado e conjuntivite alérgica
Fenotiazínicos e butirofenonas	Crise oculógira, midríase e cicloplegia
ISRSs	Glaucoma de ângulo fechado, maculopatia, crise oculógira
Lamotrigina	Oftalmoplegia
Lítio	Exoftalmo, papiledema, nistagmo e irritação nos olhos
Quetiapina	Catarata
Tioridazina	Retinopatia pigmentar
Topiramato	Miopia, glaucoma de ângulo fechado, crise oculógira e nistagmo
Valproato	Anormalidades na percepção das cores

Fonte: Com base em Richa e Yazbek.⁶⁷

Drogas com efeitos anticolinérgicos provocam diminuição do ângulo iridocorneal da câmara anterior do olho. Com isso, a drenagem do líquido dessa câmara fica comprometida, e a pressão intraocular aumenta, levando ao glaucoma. Clinicamente, o glaucoma agudo manifesta-se com intensa dor, vermelhidão e edema oculares, visão embaçada, cefaleia, náusea e fotofobia.

Em indivíduos predispostos, os antidepressivos mais arriscados são os ADTs. Os ISRSs e os antidepressivos duais têm risco moderado, e a bupropiona apresenta baixo risco. Entre os antipsicóticos, contraindica-se a olanzapina, e a clozapina requer atenção; portanto, é preferível usar haloperidol, risperidona ou paliperidona. Benzodiazepínicos e hipnóticos não oferecem risco, o que também parece ocorrer com lítio, valproato, anticolinesterásicos e memantina. Metilfenidato e lisdexanfetamina têm risco moderado. Evitar o uso de topiramato e de anticolinérgicos.⁶⁸

GRAVIDEZ

As informações desta seção encontram-se resumidas e apresentam considerações de ordem prática. Para o aprofundamento dos transtornos psiquiátricos que acometem a mulher durante a gestação e o puerpério, bem como os princípios que devem reger o uso de psicofármacos nesses períodos, recomenda-se consultar o Capítulo 21.

Ao ponderar os riscos e os benefícios do uso de psicofármacos durante a gravidez, devemos lembrar que:

- Os psicofármacos não envolvem risco para o feto apenas durante o primeiro trimestre gestacional; há riscos a serem considerados durante o segundo e terceiro trimestres.
- Certos transtornos mentais que acometem a gestante causam ao feto malefícios mais prováveis e intensos do que os psicofármacos utilizados em seu tratamento. Uma depressão não tratada, por exemplo, implica maior risco de aborto, internação psiquiátrica e suicídio e, no feto, nascimento pré-termo e baixo peso.⁶⁹

Deve-se estar atento às atualizações tanto em bancos de dados com artigos mais recentes e abrangentes (o mais conhecido é o Medline, da norte-americana National Library of Medicine, acessível pela plataforma PubMed) quanto em *sites* como os recomendados no Quadro 24.7. O American College of Obstetricians and Gynecologists e a American Academy of Pediatrics também publicam, periodicamente, atualizações sobre o tema.

QUADRO 24.7

Sites de acesso gratuito que trazem informações atualizadas sobre o uso de psicofármacos durante a gestação e a lactação

Motherisk (motherisk.org)

Site em inglês de um hospital infantil afiliado à Universidade de Toronto e à The Organization of Teratology Information Specialists – OTIS. Contém perguntas e respostas objetivas e atualizadas sobre psicofármacos na gestação e na lactação.

Antiepileptic Drug Pregnancy Registry (aedpregnancyregistry.org)

Site em inglês da organização vinculada ao Massachusetts General Hospital, financiada por várias empresas farmacêuticas. Contém informações atualizadas e minuciosas sobre o uso de anticonvulsivantes na gestação.

Sugerimos que, para cada situação clínica, o psiquiatra reserve um tempo para se informar por meio dessas fontes de referência. A pesquisa costuma levar algum tempo, e o médico deve se lembrar disso. Por isso, a resposta aos questionamentos da gestante e de seus familiares, bem como a ponderação dos prós e contras implicados no uso de um ou outro medicamento, podem ser postergados por 24 horas.

Um artigo recente fornece bom exemplo de como procedeu um ginecologista quando sua paciente, que utilizava citalopram, comunicou-lhe que estava grávida. O passo a passo da conduta do médico é descrito a partir da escolha das fontes de informação consultadas e de seu raciocínio até chegar a uma posição ponderada e cientificamente embasada. Somente então pôde dialogar com a paciente e seus familiares.⁷⁰

Antidepressivos

O grupo dos ISRSs não é isento de riscos. Há possível aumento de risco para autismo, nascimento pré-termo, aborto espontâneo, craniossinostose e hipertensão pulmonar persistente no neonato.⁷¹⁻⁷⁴ Esta última é rara, autolimitada e responde bem ao tratamento.⁷³

Os riscos não são os mesmos para todos os ISRSs, pois alguns achados indicaram que a paroxetina causaria mais malformações cardíacas (0,2% das gestações) e síndrome de abstinência no neonato.⁷⁵ Dessa maneira, é preferível a utilização de sertralina, escitalopram ou citalopram; no entanto, deve-se evitar o uso de paroxetina.

A síndrome de abstinência no neonato exposto a ISRSs no terceiro trimestre da gestação inclui irritabilidade, choro constante, aumento ou diminuição do tônus muscular, tremor, taquipneia, alterações da alimentação e convulsões. É autolimitada e geralmente necessita apenas de medidas de suporte, além de ser mais frequente com o uso de paroxetina, mas também de clomipramina e venlafaxina.⁷⁶

Os antidepressivos duais foram menos estudados que os ISRSs. Assim, devem ser reservados para pacientes que não respondem a um ou dois ISRSs ou que têm história de boa resposta a antidepressivos duais. Esperam-se riscos semelhantes aos dos ISRSs. A venlafaxina pode envolver discreto incremento do risco de pré-eclampsia e de síndrome de abstinência no neonato.⁷⁵

Os efeitos adversos dos tricíclicos são ainda mais problemáticos durante a gestação. Vortioxetina, agomelatina, trazodona e tranilcipromina não foram ainda bem estudadas.

Antipsicóticos

Os antipsicóticos típicos, de modo geral, podem se associar a parto prematuro e sintomas extrapiramidais no neonato. Os de baixa potência são associados a maiores riscos de hipotensão e efeitos anticolinérgicos e anti-histaminérgicos. Já o haloperidol não se associa a tais riscos, sendo relativamente seguro e considerado de preferência, assim como a olanzapina.⁷⁷

Os antipsicóticos atípicos podem ocasionar ganho de peso na gestante e no feto, aumento do risco de diabetes gestacional e hipoglicemia. Como parte desses problemas pode ser minimizada por meio de controle glicêmico e nutricional minucioso, a olanzapina passa a ser uma opção a pacientes que não toleram o haloperidol.

Quando da utilização de antipsicóticos atípicos, foram observados baixos níveis de folato, com consequente risco de malformações no tubo neural do feto. Recomenda-se suplementação com ácido fólico.⁷⁸

Entre os atípicos, algumas particularidades merecem ser mencionadas: o aripiprazol passa mais facilmente pela barreira placentária, e, no neonato, a clozapina se associa a hipotonia muscular e risco de agranulocitose até o sexto mês. Ainda assim, pode fazer sentido a manutenção da clozapina quando esta foi a única a alcançar melhora dos sintomas da esquizofrenia.⁷⁹

Estabilizadores do humor

O ácido valproico ocasiona malformações que podem chegar a uma frequência de 10%, com alterações de tubo neural, musculatura esquelética, face, crânio, cérebro, coração e palato, além de hipospádia. Há também risco de alterações cognitivas e na capacidade de aprendizagem. A carbamazepina se associa a alterações semelhantes, com frequência de 4%. Quando do uso desses psicofármacos durante a gravidez, recomenda-se suplementação com ácido fólico e vitamina K.⁷⁹ Deve-se evitar o uso de ácido valproico e carbamazepina, dando preferência à olanzapina.

O lítio deve ser evitado no primeiro trimestre, pois pode causar a síndrome de Ebstein. Trata-se de uma anomalia na implantação dos grandes vasos sanguíneos, ocorrendo em 1 a cada 20 mil neonatos. Essa incidência aumenta 20 vezes quando a gestante usa lítio (1:1.000).⁸⁰

A recidiva de quadros bipolares durante a gravidez e o puerpério é elevada (20-50%) quando há interrupção do lítio. Em alguns casos, deve-se optar pela manutenção dessa medicação durante a gestação, em 2 a 3 doses ao longo do dia. Em outros, interrompê-la inicialmente e reintroduzi-la após a décima semana, quando o desenvolvimento estrutural do coração se completa.

Devido ao aumento da taxa de filtração glomerular durante o segundo e terceiro trimestres da gravidez, é necessário aumentar a dose ingerida de lítio. Após o parto, com o retorno da taxa de filtração glomerular em nível basal, a litemia pode chegar a concentrações tóxicas. Recomenda-se hidratação da puérpera e retorno da dose oral de lítio aos níveis pré-gestação.

O lítio atravessa plenamente a barreira hemoplacentária. Há relatos de arritmias cardíacas, hipoglicemia, polidrâmnio, alterações reversíveis no funcionamento da tireoide e parto prematuro. Neonatos com litemias maiores que 0,6 mEq/L no momento do parto recebem Apgar menor, apresentam mais complicações neuromusculares (hipotonia, hiporreflexia, letargia) e permanecem mais tempo hospitalizados. Por isso, recomenda-se interromper o lítio de 24 a 48 horas antes do parto, o que reduz mais de um terço da litemia.⁸¹

A lamotrigina é o fármaco de menor risco, embora o número de estudos na literatura ainda seja insuficiente. Também necessita de ajuste do nível sérico com o progresso da gestação.

Hipnóticos e ansiolíticos

Alguns estudos associam benzodiazepínicos a malformações orofaciais; outros não confirmam tais achados.⁸² Os benzodiazepínicos podem causar síndrome de abstinência no neonato (irritabilidade, choro constante, tremor, diarreia, vômitos, hipertonia, convulsões, dificuldades respiratórias). Foi descrita a síndrome do bebê hipotônico (*floppy baby*), com sedação, hipotonia muscular e dificuldades respiratórias, em neonatos de mães que usavam benzodiazepínicos no terceiro trimestre até o momento do parto.⁸³ Deve-se evitar o uso de benzodiazepínicos. No entanto, caso seja necessário, é preferível o uso ocasional de drogas de meia-vida plasmática curta e que não tenham metabólitos ativos, como lorazepam e oxazepam.

Em relação a buspirona, zopiclona e zaleplon, não há dados suficientes na literatura. Há suspeitas de que o zolpidem possa ocasionar baixo peso ao nascer ou trabalho de parto prematuro. Alguns estudos mostraram leve associação de trazodona a hipertensão pulmonar no neonato, autismo, nascimento pré-termo e aborto espontâneo. Como provavelmente os riscos são dose-dependentes, e a trazodona, na função de hipnótico, é usada em baixas doses (25-100 mg), ela passa a ser relativamente segura na gestação.⁸³

Outros

Segundo uma revisão recente, um problema relativamente comum é o tratamento de gestantes dependentes de substâncias psicoativas.⁸² O uso dessas substâncias impõe considerável risco para a saúde do feto. O plano terapêutico deve combinar várias abordagens, incluindo, ainda que raramente – só para casos mais graves –, o uso de um psicofármaco.

A terapia de reposição de nicotina pode ser útil, na medida em que reduz a exposição do feto ao monóxido de carbono. A bupropiona já foi associada a teratogênese, o que não foi confirmado por uma metanálise. A vareniclina não foi estudada e não deve ser usada.

A metadona é o fármaco mais usado para evitar a intoxicação e os sintomas de abstinência por opioides. Apesar de a FDA não aprovar seu uso durante a gravidez, a metadona parece ser menos arriscada do que o uso contumaz de opioides.

HIV/AIDS

Pacientes com aids podem usar várias medicações concomitantemente, a começar pela própria associação de vários antirretrovirais. Em geral, há poucas proibições e nenhuma preferência notável entre os psicofármacos que podem ser usados em pacientes com HIV/aids. Há, no entanto, a necessidade de se averiguar meteticulosamente a existência de interações medicamentosas. Deve-se tomar cuidado com a hepatotoxicidade de certos fármacos, pois doenças hepáticas são comuns em pacientes com HIV/aids.^{84,85}

Não é possível memorizar todas as possíveis interações medicamentosas envolvidas com os psicofármacos. Reforçamos a necessidade de o leitor se familiarizar com aplicativos de interações medicamentosas que podem ser instalados em celulares, como Drugs, Epocrates e Medscape.

Antidepressivos

Os ISRSs são a principal opção, e a sertralina e o escitalopram costumam ter menor interação medicamentosa. Os duais também podem ser usados e costumam ter bom perfil de interação. Já os tricíclicos, devido aos efeitos anticolinérgicos, são mais lembrados apenas em situações de dor neuropática ou de neuropatia periférica. Metilfenidato e modafinil podem ser usados associados ou não a antidepressivos, visando aos sintomas de letargia e fadiga.^{85,86}

Antipsicóticos

Os antipsicóticos típicos têm maior risco de causar sintomas extrapiramidais e síndrome neuroléptica maligna. Os atípicos, como olanzapina, quetiapina, risperidona e clozapina, são largamente preferidos, com as cautelas já mencionadas (p. ex., ritonavir altera o nível sérico da clozapina).^{85,87}

Estabilizadores do humor

Os episódios de mania secundários ao HIV, em geral, apresentam sintomas psicóticos e são mais frequentemente disfóricos. Nessa condição, o uso da carbamazepina pode diminuir o nível sérico de várias medicações, como a etravirina e os inibidores de protease. Estes, por sua vez, frequentemente diminuem a concentração do ácido valproico.^{84,85}

Ansiolíticos e hipnóticos

A associação da buspirona com ritonavir pode provocar sintomas extrapiramidais. Em relação aos benzodiazepínicos, deve-se optar pelo lorazepam. O midazolam não deve ser usado com inibidores de protease devido ao risco de sedação prolongada.⁸⁸

IDOSOS

As funções cardíaca, pulmonar, renal, hepática e pancreática estão, em algum grau, diminuídas na idade avançada. O idoso tem redução progressiva da água do corpo, acompanhada de aumento da gordura corporal. Isso determina que as drogas hidrossolúveis (p. ex., lítio) tenham volume de distribuição menor, o que aumenta sua concentração plasmática. Contudo, as lipossolúveis têm volume maior para se distribuir, levando ao aumento de sua meia-vida (esse fenômeno ocorre com a maioria dos antidepressivos, antipsicóticos e benzodiazepínicos). Pacientes idosos podem ter algum grau de desnutrição proteica, o que acarreta diminuição das proteínas plasmáticas e consequente elevação da porção livre das drogas, com potencial aumento de sua ação. Tudo isso altera significativamente a farmacocinética da maioria das drogas.⁸⁹

Alguns cuidados necessários:

- Preferir a monoterapia e drogas com menos efeitos adversos.
- Usar inicialmente doses menores do que as habituais, com aumento paulatino.
- Ter cuidado com drogas que apresentam efeitos anticolinérgicos (pelo risco de hipotensão ortostática e quedas, glaucoma, obstipação, arritmia cardíaca e confusão mental).
- Ter cautela com drogas que inibem as enzimas do citocromo P450, pois os idosos são comumente polimedicados.
- Considerar as implicações de psicotrópicos nas comorbidades.
- Ter em mente que o risco de mortalidade aumenta quando se usa quaisquer antipsicóticos em idosos que sofrem de demência.
- Verificar cuidadosamente quais as medicações em uso e de que forma estão sendo administradas/tomadas.

Antidepressivos

Os ADTs devem ser evitados em função dos efeitos anticolinérgicos e dos distúrbios no ritmo cardíaco. Entre os ISRSs, escitalopram e sertralina são preferíveis (meia-vida em torno de 24 horas, sem metabólitos ativos e pouca interação medicamentosa), mas deve-se estar atento à possibilidade de hiponatremia, perda de peso e aumento do risco de quedas. Mirtazapina e venlafaxina também podem ser utilizadas, embora ocasionem sonolência excessiva e aumento da pressão arterial, respectivamente. A bupropiona é bem tolerada nas doses habituais.⁹⁰ De modo geral, os antidepressivos parecem ser menos efetivos em idosos com idade mais avançada.⁹¹ O metilfenidato pode ser usado como adjuvante em certas depressões com fadiga e letargia marcantes.⁹²

Antipsicóticos

Em idosos que sofrem de demência, o uso de antipsicóticos está associado a aumento de casos de acidente vascular cerebral (AVC) e de mortalidade, sendo que o haloperidol implica o maior

risco. Tal risco parece se associar a imobilidade e a desidratação, o que requer cuidados.^{93,94} Assim, sua utilização deve ser evitada.

A decisão de utilizar ou não um antipsicótico precisa ser ponderada, uma vez que certos distúrbios comportamentais, como a agitação psicomotora, implicam riscos quando não tratados. Quando necessário, deve-se dar preferência a antipsicóticos de segunda geração – sendo a quetiapina o de menor risco – e a doses baixas, pois há correlação positiva entre dose e mortalidade.^{93,94} Dessa maneira, é preferível a utilização de quetiapina ou olanzapina.

O haloperidol pode ser adequado para o tratamento de quadros agudos de agitação psicomotora, mas seu uso crônico pode causar discinesia. Fenotiazínicos provocam hipotensão postural e arritmia cardíaca, portanto, não devem ser prescritos.

Estabilizadores do humor

O carbonato de lítio deve ser prescrito com cautela, pois, além da redução natural do *clearance* renal, que ocorre no idoso, tais pacientes frequentemente fazem uso de diuréticos e, não raro, de anti-inflamatórios não hormonais.⁹⁵ Carbamazepina, divalproato e lamotrigina são mais bem tolerados; entretanto, além da sedação, ataxia, alterações hepáticas e hematológicas, deve-se ficar atento a possíveis prejuízos cognitivos. A hiponatremia pode ocorrer com a carbamazepina e a oxcarbazepina.

Ansiolíticos e hipnóticos

Os benzodiazepínicos, principalmente os de meia-vida longa, podem levar a sedação excessiva, prejuízo cognitivo, acidentes, quedas e fraturas. Em certos casos, podem ocorrer, paradoxalmente, agitação psicomotora, irritabilidade, pesadelos e até alucinações. Caso sejam imprescindíveis, os de menor meia-vida, como lorazepam e alprazolam, são preferíveis. A buspirona pode ser uma alternativa valiosa no tratamento da ansiedade. Zolpidem e zopiclona são seguros, mas há risco de quedas e fraturas, além de sonolência diurna e prejuízo da memória; portanto, é preferível iniciar com doses menores do que as habituais.⁹⁶

INSUFICIÊNCIA HEPÁTICA

A maioria dos psicofármacos é lipossolúvel e necessita do metabolismo hepático para se tornar solúvel em água e, assim, ser eliminada pelos rins ou por meio da bile. Esse processo ocorre em duas fases: na primeira, ocorre oxidação, redução ou hidrólise da droga; na segunda, têm-se as reações de conjugação, que não são comprometidas na insuficiência hepática (IH).

Para pacientes com falência hepática, pode ser bastante adequada a opção por drogas que utilizem apenas a segunda fase – a conjugação – no seu metabolismo, como acontece com o lorazepam. Diazepam, clordiazepóxido, amitriptilina, imipramina, clorpromazina, risperidona e outras são todas drogas que necessitam da primeira fase para serem metabolizadas.

A prescrição de psicofármacos para pacientes com IH precisa ser cuidadosa e deve considerar sempre a faixa terapêutica da droga, a existência ou não de encefalopatia hepática e o grau de gravidade do acometimento do fígado, que pode ser avaliado por meio da classificação de Child-Pugh (Tab. 24.4).

Tabela 24.4

Classificação de Child-Pugh

Pontuação	1 ponto	2 pontos	3 pontos
Encefalopatia	Ausente	Graus I, II	Graus III, IV
Ascite	Ausente	Leve, fácil controle	Moderada a grave, refratária
Bilirrubina (mg/dL)	< 2	2-3	> 3
Albumina (g/dL)	> 3,5	3,5-2,8	< 2,8
RNI	< 1,7	1,7-2,3	> 2,3
Soma dos pontos nos cinco fatores			
Classificação de Child-Pugh	5-6	7-9	10-15
	A	B	C

Na prática, pacientes com acometimento discreto da função hepática (Child-Pugh A) podem ser tratados com 75 a 100% da dose habitual dos medicamentos. Indivíduos classificados como Child-Pugh B necessitam de mais cautela, e as doses devem ser reduzidas para 50 a 75% das comumente utilizadas. Pacientes com Child-Pugh C frequentemente apresentam algum grau de encefalopatia hepática e devem ser medicados de forma extremamente cautelosa, inclusive para que seja evitada a piora da confusão mental e da sedação. A Tabela 24.5 relaciona alguns psicofármacos e o ajuste de dose recomendado.

Tabela 24.5

Ajustes da dose dos psicofármacos nos pacientes com insuficiência hepática

Fármacos	Consideração sobre a necessidade de ajuste da dose
ADTs* Agomelatina Duloxetina IMAOs* Metilfenidato*	Potencialmente hepatotóxico

Valproato	
Alprazolam Modafinil*	A dose deve ser reduzida pela metade. Devem ser evitados em pacientes com cirrose.
Atomoxetina	Reduzir a dose para 50%, na IH moderada, e para 75%, na grave.**
Asenapina**	Não necessita de ajuste de dose na IH leve a moderada, mas não deve ser usada na IH grave.
Bupropiona	Mesmo na IH leve, a dose deve ser reduzida. Na IH grave, a dose não deve ultrapassar 75 mg/dia para a apresentação convencional; para comprimidos de liberação estendida, a dose pode chegar a 150 mg/dia, em dias alternados.
Carbamazepina	É extensamente metabolizada pelo fígado. Recomenda-se avaliação inicial da função hepática antes do início do tratamento e, depois, a cada seis meses. A concentração plasmática de carbamazepina deve servir de parâmetro para o ajuste da dose.*
Clordiazepóxido Clonazepam Diazepam Fenotiazínicos Flurazepam Triazolam	O <i>clearance</i> apresenta-se diminuído, e a meia-vida, aumentada. Evitar o uso.
Clozapina	Deve ser suspensa em pacientes com elevação de transaminases ou icterícia.
Galantamina	Contraindicada a pacientes com Child-Pugh de 10 a 15. A dose não deve exceder 16 mg/dia naqueles com Child-Pugh de 7 a 9. O uso deve ser cauteloso em caso de IH leve a moderada.
Haloperidol Trazodona	São metabolizados inteiramente pelo fígado.*
ISRSs	Dose inicial 50% menor do que a habitual, aumento em intervalos mais longos. A dose final normalmente é menor do que aquela em indivíduos hígidos.
Lamotrigina	A dose inicial e a de manutenção devem ser reduzidas para 50%, na IH moderada, e para 75%, na grave. Os intervalos para os aumentos das doses também devem ser maiores.
Lítio	Recomenda-se cautela, pois na IH podem ocorrer edema e alterações dos eletrólitos, e o uso de diurético é comum.
Lorazepam	É o benzodiazepínico de preferência, pois seu <i>clearance</i> não sofre alteração, e a dose não necessita de ajuste.
Lurasidona	A dose não deve ultrapassar 40 mg/dia em caso de IH leve a moderada.
Aripiprazol Gabapentina*** Memantina** Pregabalina	Todos são eliminados pelos rins, portanto, nenhum ajuste é necessário.
Mirtazapina Donepezila Topiramato	O <i>clearance</i> apresenta-se reduzido.*
Olanzapina	Não necessita de ajustes, e sim de monitoramento das transaminases.**
Oxcarbazepina** Vilazodona** Vortioxetina**	Nenhum ajuste é necessário na IH moderada.
Paliperidona	Excretada primariamente por via renal. Não necessita de ajuste na IH moderada. Não há orientação disponível para a IH grave.
Quetiapina	O <i>clearance</i> está reduzido em 30%. A dose inicial deve ser de 25 mg/dia, e o aumento, de 25-50 mg/dia.
Risperidona	A fração da droga livre é aumentada em 35% na IH. A dose máxima deve ser de 2 mg 2 vezes ao dia. O fabricante recomenda cautela.
Rivastigmina	<i>Clearance</i> reduzido em 60-65% na IH leve a moderada, mas não são necessários ajustes de dose.
Venlafaxina	A dose deve ser reduzida para 50% na IH moderada.**
Ziprasidona	A meia-vida e o nível sérico são aumentados na IH moderada. Entretanto, o fabricante sugere que não há necessidade de ajustes.
Zolpidem Zopiclona	Na IH grave, a dose deve ser reduzida pela metade.

ADTs, antidepressivos tricíclicos; IH, insuficiência hepática; IMAOs, inibidores da monoaminoxidase; ISRSs, inibidores seletivos da recaptação de serotonina.

* A orientação relacionada à dose está indisponível; ** informação do fabricante; *** na IH grave, a dose não deve exceder 100 mg/dia.

O site LiverTox⁹⁷ é uma iniciativa da National Library of Medicine e do National Institutes of Health, dos Estados Unidos, que disponibiliza gratuitamente informações atualizadas sobre hepatotoxicidade induzida por medicamentos, drogas, fitoterápicos e suplementos dietéticos. Recomendamos utilizá-lo periodicamente, para prescrições mais seguras.

Antipsicóticos

As drogas com muito efeito anticolinérgico devem ser evitadas, pois podem desencadear encefalopatia hepática. É o caso dos ADTs e do antipsicóticos de baixa potência. A clorpromazina apresenta, ainda, o risco de hepatotoxicidade. A paliperidona e o aripiprazol são os únicos que não necessitam de ajuste de dose.⁹⁹

Antidepressivos

Os antidepressivos raramente são hepatotóxicos, mas podem causar alterações discretas e passageiras das transaminases. Entretanto, a duloxetina está relacionada a hepatotoxicidade grave em pacientes com doença hepática prévia e não deve ser utilizada nessa população.^{105,106}

A agomelatina e os IMAOs também apresentam risco aumentado de hepatite tóxica.^{99, 107,108} Os ADTs devem ser evitados pelos seus efeitos anticolinérgicos. A vortioxetina não necessita de ajuste de dose nos casos de insuficiência hepática leve ou moderada.^{103,104} Mesmo nos casos de insuficiência grave, a vilazodona não apresentou alterações em sua concentração sérica.¹⁰⁹

Anticonvulsivantes e lítio

O lítio é excretado por via renal; entretanto, curiosamente, sua dose deve ser reduzida, e seu monitoramento, cuidadoso, devido às variações frequentes no equilíbrio hidreletrolítico dos pacientes hepatopatas, principalmente naqueles que apresentam ascite ou que fazem uso de diuréticos. Devido ao risco de hepatotoxicidade, carbamazepina e valproato devem ser evitados. Gabapentina e oxcarbazepina parecem não requerer ajustes em suas doses.⁹⁹

Ansiolíticos e hipnóticos

Se não houver como evitar o uso de benzodiazepínicos – o mais desejável –, a preferência deverá ser pelo lorazepam, cujo metabolismo não se altera nesses doentes. No entanto, deve-se ter em mente que pacientes com confusão mental ou risco de desenvolvê-la não devem, em princípio, ser tratados com benzodiazepínicos.

Anticolinesterásicos e memantina

A memantina é excretada predominantemente por via renal e não exige ajuste de dose na IH. Donepezila, galantamina e rivastigmina necessitam de certa redução nas doses de acordo com a gravidade da doença hepática.

Psicoestimulantes

Não há dados que permitam fazer recomendações a respeito da dose do metilfenidato em pacientes com IH. A dose do modafinil deve ser reduzida em 50% nos casos de IH grave. A recomendação do fabricante da atomoxetina é a de que, em tais casos, a dose seja reduzida de 50 a 75% daquela habitualmente usada.

INSUFICIÊNCIA RENAL

Com exceção do carbonato de lítio e da gabapentina, as drogas psicotrópicas dependem pouco da excreção renal. No entanto, qualquer que seja a causa da insuficiência renal (IR) e o tratamento substitutivo a que, porventura, o paciente esteja se submetendo, podem ocorrer alterações na absorção, distribuição, metabolização e excreção das drogas, com mudanças significativas de seus comportamentos no organismo (Quadro 24.8). Isso justifica uma atenção especial à possível necessidade de ajustes da dose dos medicamentos, que podem ser baseados no ritmo de filtração glomerular (Tab. 24.6).

QUADRO 24.8

Alterações farmacocinéticas secundárias à insuficiência renal

Diminuição da absorção	■ Aumento do pH do estômago pelo aumento da uremia e uso de antiácidos ■ Náusea e vômitos ■ Edema da mucosa intestinal e deficiência de vitamina D
Aumento da distribuição	■ Diminuição das proteínas plasmáticas ■ Expansão do volume extravascular (edema)
Alteração do metabolismo	■ A insuficiência renal leva a imprevisível alteração da capacidade do fígado de metabolizar as drogas
Excreção	■ Diminuição proporcional ao declínio do <i>clearance</i> de creatinina em boa parte das drogas

Tabela 24.6

Estágios da insuficiência renal

Estágio	Descrição	RFG (mL/min/1,73 m ²)
1	Lesão renal com RFG normal ou ↑	≥ 90
2	Lesão renal com ↓ RFG leve	60-89
3	↓ RFG moderada	30-59
4	↓ RFG grave	15-29
5	Falência renal	< 15 ou diálise

RFG; ritmo de filtração glomerular.

Para o doente renal, assim como ocorre em pacientes geriátricos ou naqueles com insuficiência hepática, a conduta de iniciar o tratamento farmacológico com dose baixa, aumentando-a lentamente (*start low, go slow*), traduz-se em uma boa prática clínica.

O trabalho de Cohen e colaboradores¹¹⁰ traz uma grande tabela com as características dos medicamentos comumente usados no tratamento de comorbidades psiquiátricas em pacientes com doença renal.

Antipsicóticos

O haloperidol continua sendo o neuroléptico de escolha para manejo farmacológico da agitação e tratamento dos quadros de *delirium*, já que apenas 1% da droga é excretada na urina.¹¹⁰

Já a ziprasidona é provavelmente o antipsicótico que mais deve ser evitado, pois pode causar arritmia cardíaca pelo prolongamento de QT.¹¹⁰ A paliperidona necessita de redução de dose por ser excretada de forma inalterada na urina.^{111,112} O *clearance* da risperidona e de seus metabólitos ativos está reduzido em até 60% na IR.¹¹³ A olanzapina é extensamente metabolizada pelo fígado, e seus metabólitos são excretados na urina. A dose da lurasidona também deve ser reduzida em 50% nos pacientes com *clearance* < 50mL/min^[NT]. As informações a respeito do uso da clozapina nessa população são extremamente escassas. Dessa maneira, o uso de paliperidona, ziprasidona e clozapina deve ser evitado.

Não há necessidade de ajustes com olanzapina, aripiprazol, asenapina e quetiapina nos pacientes com insuficiência renal.^{110,114,115}

Antidepressivos

- Evitar: fluvoxamina e paroxetina.

Citalopram, escitalopram e sertralina provavelmente são os agentes com menor potencial de interação medicamentosa. Os dados sobre a necessidade ou não de ajustes de dose são controversos, mas em geral as três são consideradas drogas bem toleradas.^{100,110,112,116} Uma potencial vantagem dos ISRSs é a diminuição da hipotensão ortostática em pacientes submetidos à hemodiálise.¹¹⁶

A concentração e a meia-vida dos metabólitos dos ADTs estão aumentadas nos pacientes com variados graus de insuficiência renal. Considerando o risco do efeito anticolinérgico dos ADTs (hipotensão ortostática, arritmia cardíaca e confusão mental), a dose inicial deve ser a metade da habitual, e o aumento, lento, gradual e cuidadoso. Portanto, a nortriptilina pode ser uma boa escolha.^{100,112}

A meia-vida da venlafaxina é prolongada na IR, e seu *clearance*, reduzido à metade nos pacientes em hemodiálise. Seu perfil de interação com outras drogas e o baixo potencial de cardiotoxicidade colocam-na como uma droga segura; entretanto, os efeitos adversos gastrointestinais e a hipertensão arterial podem impedir a utilização dessa droga com segurança.¹¹⁷ A dose da desvenlafaxina também exige redução na IR moderada.¹¹²

A duloxetine e a vilazodona não necessitam de ajustes de dose nos casos de IR moderada, mas a primeira deve ser evitada em pacientes com IR grave.^{118,119}

A vortioxetina não demonstrou necessitar de ajuste de dose em pacientes com IR de moderada a grave.¹²⁰ Entretanto, como ainda é uma droga nova no mercado, o fabricante recomenda cautela quando prescrita a pacientes com IR.

O *Hypericum perforatum*, hipérico, ou erva-de-são-joão, é um fitoterápico com propriedades antidepressivas que pode induzir a enzima hepática CYP3A4. Como consequência, pode reduzir os níveis de drogas inibidoras da calcineurina, como os imunossupressores ciclosporina e tacrolimus, aumentando, assim, o risco de rejeição do enxerto em pacientes submetidos a

transplante.¹²¹No entanto, vários antidepressivos podem potencializar o efeito desses agentes, por meio da inibição da mesma enzima. Fluvoxamina, fluoxetina, nefazodona, sertralina e paroxetina, portanto, devem ser utilizadas com cautela.

Estabilizadores do humor

O carbonato de lítio é totalmente excretado pelos rins e está contraindicado a pacientes com IR aguda. Apesar dos efeitos nefrotóxicos dessa droga, alguns pacientes não respondem a outros estabilizadores do humor. Nesses casos, o lítio deve ser administrado em dose única (300-600 mg), sempre após a sessão de hemodiálise, e sua dosagem sérica deve ser feita 3 horas após o término da sessão.¹¹² Topiramato, gabapentina, lamotrigina e valproato podem ser parcialmente removidos com a hemodiálise e precisam de suplementação da dose após a sessão.¹²²

Ansiolíticos e hipnóticos

Benzodiazepínicos que tenham metabólitos inativos, como lorazepam e oxazepam, são preferíveis. Cabe, entretanto, destacar um estudo que demonstrou aumento de 15% na mortalidade de pacientes em diálise que usaram benzodiazepínicos ou zolpidem.¹²³

Outros psicofármacos

Ainda não há estudos suficientes sobre o efeito da IR sobre o metilfenidato e o modafinil. Essas drogas podem baixar o limiar convulsivo e devem, portanto, ser prescritas com cautela nessa população.¹⁰⁰

LACTAÇÃO

O uso de psicofármacos durante a lactação é um tema especialmente difícil de ser sintetizado, não só pela complexidade, mas pelas constantes atualizações. Assim, nesta seção, os dados estão resumidos, e recomenda-se que o leitor sempre consulte os *sites* aqui sugeridos (Quadro 24.7).

Uma maneira de inferir o risco de um psicofármaco na lactação é por meio do cálculo da dose relativa no neonato, que leva em conta a quantidade do psicofármaco excretada no leite da mãe, a quantidade de leite ingerida por dia e o peso do bebê. Doses inferiores a 10% são consideradas de baixo risco. Bupropiona, venlafaxina, desvenlafaxina, mirtazapina, duloxetine, citalopram, escitalopram, sertralina, fluvoxamina e paroxetina geralmente estão associados a doses relativas inferiores a 10% no neonato, o que permite certa segurança de uso desses fármacos pela lactante. Destes, sertralina e paroxetina são os que produzem as menores doses, em geral abaixo de 3%. A fluoxetine é um dos poucos antidepressivos cuja dose relativa frequentemente passa dos 10%, mas mesmo assim costuma ficar entre 10 e 12%, o que se considera um risco apenas moderado.¹²⁴

Há revisões sistemáticas sobre o uso de antipsicóticos de segunda geração e de estabilizadores do humor na lactação. Na primeira revisão, foram selecionados 37 estudos, e não se encontraram efeitos preocupantes para o lactente. No entanto, mais de 80% destes foram expostos à olanzapina, uma vez que os estudos publicados destacavam sua segurança. Tal fato escasseia os dados a respeito dos outros antipsicóticos atípicos.¹²⁵ Na segunda revisão, foram selecionados 26 estudos, e também não se encontraram resultados preocupantes, embora os dados a respeito de ácido valproico, lítio e oxcarbazepina fossem escassos.¹²⁶

Em um seguimento de 124 mães em uso de benzodiazepínicos durante a lactação, só se observou sedação em 1,6% dos lactentes, o que sugere haver segurança relativa desses fármacos na lactação.¹²⁷

Alguns psicotrópicos já foram associados a risco em estudos de seguimento e podem implicar risco considerável, devendo ser evitados os seguintes: ziprasidona, levomepromazina, agomelatina, lítio, vareniclina e dissulfiram.^{75,128}

Se um transtorno mental se iniciou na gestação e continua durante o puerpério, em geral, não se interrompe o psicofármaco já iniciado, devido à suscetibilidade do período puerperal a transtornos mentais. Os *sites* do Quadro 24.9 são fontes confiáveis que auxiliam a decisão sobre o uso de determinado psicofármaco durante o período de lactação.

QUADRO 24.9

Sites com informações atualizadas sobre o uso de psicofármacos durante a lactação

LactMed

Site em inglês da National Library of Medicine com informações sobre a concentração de drogas no leite materno e no soro do lactente, possíveis efeitos na lactação e efeitos adversos no bebê, além de sugestões de drogas alternativas. Produtos de origem herbácea também estão presentes. Atualização mensal.

E-lactancia

Site prático, em inglês ou espanhol, organizado pela Asociación para la Promoción e Investigación Científica y Cultural de la Lactancia Materna – APILAM.

DOENÇA DE PARKINSON

Antipsicóticos

Sintomas psicóticos frequentemente estão relacionados ao tratamento antiparkinsoniano e entram em remissão com o ajuste das doses. Quando necessários, os antipsicóticos atípicos são os mais promissores, por ocasionarem menos sintomas extrapiramidais e acatisia. Contudo, o uso de antipsicóticos atípicos esteve associado a maior mortalidade, graves eventos adversos, efeitos colaterais relacionados à cognição, piora do parkinsonismo, infecção e edema periférico.¹²⁹ Apesar de os sintomas psicóticos serem angustiantes para muitos pacientes com doença de Parkinson, é importante que seu uso seja evitado e restrito ao mínimo período necessário.

Um estudo de metanálise mostrou eficácia do uso de clozapina em baixas doses (6,25-50 mg/dia) no tratamento de sintomas psicóticos sem piorar os sintomas da doença de Parkinson.¹³⁰

Antidepressivos

- Preferíveis: tricíclicos.
- Evitar: ISRSs.

Tricíclicos devem ser considerados como primeira linha em pacientes com doença de Parkinson, pois seu efeito anticolinérgico é benéfico.¹³¹ Os ISRSs e ISRSNs, ocasionalmente, podem exacerbar sintomas motores. A agomelatina parece ser uma possibilidade no tratamento da depressão, além de melhorar o sono em pessoas com doença de Parkinson.^{132,133}

Ansiolíticos e hipnóticos

A buspirona tem resultados promissores, atenuando a discinesia relacionada à doença de Parkinson.¹³⁴ Deve-se evitar o uso de benzodiazepínicos, especialmente quando prejuízo cognitivo estiver associado. Zolpidem, zaleplon e zopiclona podem ser utilizados com segurança.¹³⁵

Estabilizadores do humor

Quadros de hipomania e mania costumam estar associados à terapia de reposição de dopamina na doença de Parkinson, com prevalência de 17%.¹³⁶ Também existem relatos de hipomania/mania com o uso de pergolida, bromocriptina, pramipexol e realização de estimulação cerebral profunda.¹³⁷⁻¹³⁹

Outros

A qualidade das evidências em relação ao modafinil ainda é limitada.¹⁴⁰ Metilfenidato e atomoxetina podem melhorar a hipocinesia e a impulsividade, respectivamente.^{141,142} Uma revisão sistemática de Wang e colaboradores¹⁴³ não demonstrou efeitos adversos graves com anticolinesterásicos.

REFERÊNCIAS

1. Trifiró G, Sultana J, Spina E. Are the safety profiles of antipsychotic drugs used in dementia the same? An updated review of observational studies. *Drug Saf.* 2014;37(7):501-20.
2. Eskes GA, Lanctôt KL, Herrmann N, Lindsay P, Bayley M, Bouvier L, et al. Canadian stroke best practice recommendations: mood, cognition and fatigue following stroke practice guidelines, update 2015. *Int J Stroke.* 2015;10(7):1130-40.
3. Coupland C, Dhiman P, Morriss R, Arthur A, Barton G, Hippisley-Cox J. Antidepressant use and risk of adverse outcomes in older people: population based cohort study. *BMJ.* 2011;343:d4551.
4. Akoudad S, Aarts N, Noordam R, Ikram MA, Tiemeier H, Hofman A, et al. Antidepressant use is associated with an increased risk of developing microbleeds. *Stroke.* 2016;47(1):251-4.
5. Carta MG, Pala AN, Finco G, Musu M, Moro MF. Depression and cerebrovascular disease: Could vortioxetine represent a valid treatment option? *Clin Pract Epidemiol Ment Health.* 2015;11:144-9.
6. Shash D, Kurth T, Bertrand M, Dufouil C, Barberger-Gateau P, Berr C, et al. Benzodiazepine, psychotropic medication, and dementia: a population-based cohort study. *Alzheimers Dement.* 2016;12(5):604-13.
7. Campbell Burton C, Holmes J, Murray J, Gillespie D, Lightbody CE, Watkins CL, et al. Interventions for treating anxiety after stroke. *Cochrane Database Syst Rev.* 2011; (12):CD008860.
8. Huang W-S, Tsai C-H, Lin C-C, Muo C-H, Sung F-C, Chang Y-J, et al. Relationship between zolpidem use and stroke risk: a taiwanese population--based case-control study. *J Clin Psychiatry.* 2013;74(5):433-8.
9. Lan C, Liu C, Lin C, Lan T, McInnis MG, Chan C, et al. A reduced risk of stroke with lithium exposure in bipolar disorder: a population-based retrospective cohort study. *Bipolar Disord.* 2015;17(7):705-14.
10. Ramasubbu R. Lamotrigine treatment for post-stroke pathological laughing and crying. *Clin Neuropharmacol.* 2003;26(5):233-5.
11. Himelhoch S, Haller E. Extreme mood lability associated with systemic lupus erythematosus and stroke successfully treated with valproic acid. *J Clin Psychopharmacol.* 1996;16(6):469.
12. Wang Z-F, Fessler EB, Chuang D-M. Beneficial effects of mood stabilizers lithium, valproate and lamotrigine in experimental stroke models. *Acta Pharmacol Sin.* 2011;32(12):1433-45.
13. Bath PM, Wardlaw JM. Pharmacological treatment and prevention of cerebral small vessel disease: a review of potential interventions. *Int J Stroke.* 2015;10(4): 469-78.
14. Westover AN, Halm EA. Do prescription stimulants increase the risk of adverse cardiovascular events? A systematic review. *BMC Cardiovasc Disord.* 2012;12(1):1.

15. Sheng P, Hou L, Wang X, Wang X, Huang C, Yu M, et al. Efficacy of modafinil on fatigue and excessive daytime sleepiness associated with neurological disorders: a systematic review and meta-analysis. *PLoS One*. 2013;8(12):e81802.
16. Bhate K, Williams HC. What's new in acne? An analysis of systematic reviews published in 2011-2012. *Clin Exp Dermatol*. 2014;39(3): 273-7.
17. Ludot M, Mouchabac S, Ferreri F. Inter-relationships between isotretinoin treatment and psychiatric disorders: depression, bipolar disorder, anxiety, psychosis and suicide risks. *World J Psychiatry*. 2015;5(2):222-7.
18. Hanna KJ, Agnieszka KP, Michal D, Dariusz J, Izabela D, Agata M, et al. Affective disorders as potential complication of anti-acne treatment with isotretinoin: a case series. *J Affect Disord*. 2016;204:154-8.
19. Mehta RD, Roth AJ. Psychiatric considerations in the oncology setting. *CA Cancer J Clin*. 2015;65(4):300-14.
20. Ferrando SJ, Owen JA. Oncology. In: Ferrando SJ, Levenson JL, Owen JA, editors. *Clinical manual of psychopharmacology in the medically III*. Washington: APA; 2010. p. 237-69.
21. Thekdi SM, Trinidad A, Roth A. Psychopharmacology in cancer. *Curr Psychiatry Rep*. 2015;17(1):529.
22. Sanjida S, Janda M, Kissane D, Shaw J, Pearson SA, DiSipio T, et al. A systematic review and meta-analysis of prescribing practices of antidepressants in cancer patients. *Psychooncology*. 2016;25(9):1002-16.
23. Langley-DeGroot M, Ma JD, Hirst J, Roeland EJ. Olanzapine in the treatment of refractory nausea and vomiting: a case report and review of the literature. *J Pain Palliat Care Pharmacother*. 2015;29(2):148-52.
24. Ramaswami R, Villarreal MD, Pitta DM, Carpenter JS, Stebbing J, Kalesan B. Venlafaxine in management of hot flashes in women with breast cancer: a systematic review and meta-analysis. *Breast Cancer Res Treat*. 2015;152(2):231-7.
25. Doraiswamy PM, Schott G, Star K, Edwards R, Mueller-Oerlinghausen B. Atypical antipsychotics and pituitary neoplasms in the WHO database. *Psychopharmacol Bull*. 2007;40(1):74-6.
26. Ostuzzi G, Matcham F, Dauchy S, Barbui C, Hotopf M. Antidepressants for the treatment of depression in people with cancer. *Cochrane Database Syst Rev*. 2015;(6):CD011006.
27. de Jong FA1, van der Bol JM, Mathijssen RH, Loos WJ, Mathôt RA, Kitzen JJ, et al. Irinotecan chemotherapy during valproic acid treatment: pharmacokinetic interaction and hepatotoxicity. *Cancer Biol Ther*. 2007;6(9):1368-74.
28. Peuckmann V, Elsner F, Krumm N, Trottenberg P, Radbruch L. Pharmacological treatments for fatigue associated with palliative care. *Cochrane Database Syst Rev*. 2010;11:CD006788.
29. Shapiro PA. Cardiovascular disorders. In: Levenson JL, editor. *The American psychiatric publishing textbook of psychosomatic medicine: psychiatric care of the medically III*. 2nd ed. Washington: APA; 2010. p. 181-211.

30. Rey E, Tréluyer J-M, Pons G. Drug disposition in cystic fibrosis. *Clin Pharmacokinet.* 1998;35(4):313-29.
31. Kroon LA. Drug interactions with smoking. *Am J Health Syst Pharm.* 2007;64(18):1917-21.
32. Wu C, Tsai Y, Tsai H. Antipsychotic drugs and the risk of ventricular arrhythmia and/or sudden cardiac death: a nation-wide case-crossover study. *J Am Heart Assoc.* 2015;4(2). pii: e001568.
33. Levenson JL, editor. The american psychiatric publishing textbook of psychosomatic medicine: psychiatric care of the medically III. 2nd ed. Washington: APA; 2010.
34. Lam RW. Psychopharmacology for the clinician. Antidepressants and QTc prolongation. *J Psychiatry Neurosci.* 2013;38(2): E5-6.
35. Mahdanian AA, Rej S, Bacon SL, Ozdin D, Lavoie KL, Looper K. Serotonergic antidepressants and perioperative bleeding risk: a systematic review. *Expert Opin Drug Saf.* 2014;13(6):695-704.
36. Berry RB, Patel PB. Effect of zolpidem on the efficacy of continuous positive airway pressure as treatment for obstructive sleep apnea. *Sleep.* 2006;29(8):1052-6.
37. Beach SR, Celano CM, Huffman JC, Stern TA. Handbook of psychocardiology. Singapore: Springer; 2015.
38. Turkel SB, Cafaro DR. Lithium treatment of a bipolar patient with cystic fibrosis. *Am J Psychiatry.* 1992;149(4):574.
39. Yamaguchi H, Nagumo K, Nakashima T, Kinugawa Y, Kumaki S. Life-threatening QT prolongation in a boy with attention-deficit/hyperactivity disorder on atomoxetine. *Eur J Pediatr.* 2014;173(12):1631-4.
40. Parnell H, Quirke G, Farmer S, Adeyemo S, Varney V. The successful treatment of hypercapnic respiratory failure with oral modafinil. *Int J Chron Obstruct Pulmon Dis.* 2014;9:413-9.
41. Kuan Y, Wu D, Huang K, Chi N, Hu C, Chung C, et al. Effects of modafinil and armodafinil in patients with obstructive sleep apnea: a meta-analysis of randomized controlled trials. *Clin Ther.* 2016;38(4):874-88.
42. Harrison-Woolrych DM, Maggo S, Tan M, Savage R, Ashton J. Cardiovascular events in patients taking varenicline. *Drug Saf.* 2012;35(1):33-43.
43. Kayrak M, Yazici M, Ayhan SS, Koc F, Ulgen MS. Complete atrioventricular block associated with rivastigmine therapy. *Am J Health Syst Pharm.* 2008;65(11):1051-3.
44. Catalani B, Hamilton CS, Herron EW, Urman RD, Fox CJ, Kaye AD. Psychiatric agents and implications for perioperative analgesia. *Best Pract Res Clin Anaesthesiol.* 2014;28(2):167-81.
45. Hachenberg T, Schneemilch C. Anesthesia in neurologic and psychiatric diseases: is there a 'best anesthesia' for certain diseases? *Curr Opin Anaesthesiol.* 2014;27(4):394-402.
46. Ferrando SJ, Levenson JL, Owen JA. Surgery and critical care. In: Levenson JL, editor. The American psychiatric publishing textbook of psychosomatic medicine: psychiatric care of the medically III. 2nd ed. Washington: APA; 2010.

47. Huyse FJ, Touw DJ, van Schijndel RS, de Lange JJ, Slaets JP. Psychotropic drugs and perioperative period: a proposal for a guide in elective surgery. *Psychosomatics*. 2006;47(1):8-22.
48. American Society for Anesthesiology. The ASA classification of physical status. *Anaesthesiology*. 1978;49:233-6.
49. Institute.progress.im [Internet]. Denmark: c2016 [capturado em 25 jan. 2017]. Disponível em: <http://institute.progress.im/en>.
50. Jeong BO, Kim SW, Kim SY, Kim JM, Shin IS, Yoon JS. Use of serotonergic antidepressants and bleeding risk in patients undergoing surgery. *Psychosomatics*. 2014;55(3):213-20.
51. Russell WJ. The impact of Alzheimer's disease medication on muscle relaxants. *Anaesthesia Intensive Care*. 2009;37(1):134-5.
52. Ferrando SJ, Levenson JL, Owen JA, editors. *Clinical manual of psychopharmacology in the medically III*. Washington: APA; 2010.
53. Hachenberg T, Schneemilch C. Anesthesia in neurologic and psychiatric diseases: is there a best anesthesia for certain diseases? *Curr Opin Anaesthesiol*. 2014;27(4):394-402.
54. López-Jaramillo P, Sánchez RA, Diaz M, Cobos L, Bryce A, Parra-Carrillo JZ, et al. Latin American consensus on hypertension in patients with diabetes type 2 and metabolic syndrome. *J Hypertens*. 2013;31(2):223-38.
55. Alberti K, Eckel RH, Grundy SM, Zimmet PZ, Cleeman JI, Donato KA, et al. Harmonizing the metabolic syndrome a joint interim statement of the international diabetes federation task force on epidemiology and prevention; national heart, lung, and blood institute; American heart association; world heart federation; international atherosclerosis society; and international association for the study of obesity. *Circulation*. 2009;120(16):1640-5.
56. Meyer JM, Mao Y, Pikalov A, Cucchiaro J, Loebel A. Weight change during long-term treatment with lurasidone: pooled analysis of studies in patients with schizophrenia. *Int Clin Psychopharmacol*. 2015;30(6):342-50.
57. Galling B, Roldán A, Nielsen RE, Nielsen J, Gerhard T, Carbon M, et al. Type 2 diabetes mellitus in youth exposed to antipsychotics: a systematic review and meta-analysis. *JAMA*. 2016;73(3):247-59.
58. Serretti A, Mandelli L, Laura M. Antidepressants and body weight: a comprehensive review and meta-analysis. *J Clin Psychiatry*. 2010;71(10):1259-72.
59. Finnerup NB, Attal N, Haroutounian S, McNicol E, Baron R, Dworkin RH, et al. Pharmacotherapy for neuropathic pain in adults: a systematic review and meta-analysis. *Lancet Neurol*. 2015;14(2):162-73.
60. Mula M. The pharmacological management of psychiatric comorbidities in patients with epilepsy. *Pharmacol Res*. 2016;107:147-53.
61. Kanner AM. The use of psychotropic drugs in epilepsy: what every neurologist should know. *Semin Neurol*. 2008;28(3):379-88.
62. Brandt C, Mula M. Anxiety disorders in people with epilepsy. *Epilepsy Behav*. 2016;59:87-91.

63. Nolan SJ, Marson AG, Weston J, Tudur Smith C. Carbamazepine versus phenobarbitone monotherapy for epilepsy: an individual participant data review. *Cochrane Database Syst Rev*. 2015(7):CD001904.
64. Andrade C. A method for deciding about the possible safety of modafinil and armodafinil in patients with seizure disorder. *J Clin Psychiatry*. 2016;77(1):e25-8.
65. Marimuthu P, Varadarajan S, Krishnan M, Shanmugam S, Kunjuraman G, Ravinder JR, et al. Evaluating the efficacy of memantine on improving cognitive functions in epileptic patients receiving anti-epileptic drugs: a double-blind placebo-controlled clinical trial (phase IIIB pilot study). *Ann Indian Acad Neurol*. 2016;19(3):344-50.
66. Leeman-Markowski BA, Schachter SC. Treatment of cognitive deficits in epilepsy. *Neurologic Clinics*. 2016;34(1):183-204.
67. Richa S, Yazbek JC. Ocular adverse effects of common psychotropic agents: a review. *CNS Drugs*. 2010;24(6):501-26.
68. Ah-kee EY, Egong E, Shafi A, Lim LT, Yim JL. A review of drug-induced acute angle closure glaucoma for non-ophthalmologists. *Qatar Med J*. 2015;2015(1):6.
69. Koren G, Nordeng H. Antidepressant use during pregnancy: the benefit-risk ratio. *Am J Obstet Gynecol*. 2012;207(3):157-63.
70. Temming LA, Cahill AG, Riley LE. Clinical management of medications in pregnancy and lactation. *Am J Obstet Gynecol*. 2016;214(6):698-702.
71. Bérard A, Zhao JP, Sheehy O. Sertraline use during pregnancy and the risk of major malformations. *Am J Obstet Gynecol*. 2015;212(6):795.e1-795.e12.
72. Huybrechts KF, Sanghani RS, Avorn J, Urato AC. Preterm birth and antidepressant medication use during pregnancy: a systematic review and meta-analysis. *PLoS One*. 2014;9(3):e92778.
73. Huybrechts KF, Bateman BT, Palmsten K, Desai RJ, Paterno E, Gopalakrishnan C, et al. Antidepressant use late in pregnancy and risk of persistent pulmonary hypertension of the newborn. *JAMA*. 2015;313(21):2142-51.
74. Boukhris T, Sheehy O, Mottron L, Bérard A. Antidepressant use during pregnancy and the risk of autism spectrum disorder in children. *JAMA Pediatr*. 2016;170(2):117-24.
75. Chisolm MS, Payne JL. Management of psychotropic drugs during pregnancy. *BMJ*. 2016;20(532):h5918.
76. Klinger G, Merlob P. Selective serotonin reuptake inhibitor induced neonatal abstinence syndrome. *Isr J Psychiatry Relat Sci*. 2008;45(2):107-13.
77. Gentile S. Antipsychotic therapy during early and late pregnancy. A systematic review. *Schizophr Bull*. 2010;36:518-44.
78. Einarson A, Boskovic R. Use and safety of antipsychotic drugs during pregnancy. *J Psychiatr Pract*. 2009;15(3):183-92.
79. Chisolm MS, Payne JL. Management of psychotropic drugs during pregnancy. *BMJ*. 2016;532:h5918.

80. Giles JJ, Bannigan JG. Teratogenic and developmental effects of lithium. *Curr Pharm Des.* 2006;12(12):1531-41.
81. Newport DJ, Calamaras MR, DeVane CL, et al. Atypical antipsychotic administration during late pregnancy: placental passage and obstetrical outcomes. *Am J Psychiatry.* 2007;164(8):1214-20.
82. McLafferty LP, Becker M, Dresner N, Meltzer-Brody S, Gopalan P, Glance J, et al. Guidelines for the management of pregnant women with substance use disorders. *Psychosomatics.* 2016;57(2):115-30.
83. Okun ML, Ebert R, Saini B. A review of sleep-promoting medications used in pregnancy. *Am J Obstet Gynecol.* 2015;212(4):428-41.
84. Okulicz JF, Grandits GA, French JA, Perucca E, George JM, Landrum ML, et al. The impact of enzyme-inducing anti-epileptic drugs on antiretroviral drug levels: a case-control study. *Epilepsy Res.* 2013;103(2-3):245-53.
85. Singer EJ, Thames AD. neurobehavioral manifestations of human immunodeficiency virus/AIDS: diagnosis and treatment. *Neurol Clin.* 2016;34(1):33-53.
86. Nanni MG, Caruso R, Mitchell AJ, Meggiolaro E, Grassi L. Depression in HIV infected patients: a review. *Curr Psychiatry Rep.* 2015;17(1):530.
87. Hill L, Lee KC. Pharmacotherapy considerations in patients with HIV and psychiatric disorders: focus on antidepressants and antipsychotics. *Ann Pharmacother.* 2013;47(1):75-89.
88. Hsu AJ, Carson KA, Yung R, Pham PA. Severe prolonged sedation associated with coadministration of protease inhibitors and intravenous midazolam during bronchoscopy. *Pharmacotherapy.* 2012;32(6):538-45.
89. Trifirò G, Spina E. Age-related changes in pharmacodynamics: focus on drugs acting on central nervous and cardiovascular systems. *Curr Drug Metab.* 2011;12(7):611-20.
90. Hewett K, Chrzanowski W, Jokinen R, Felgentreff R, Shrivastava RK, Gee MD, et al. Double-blind, placebo-controlled evaluation of extended-release bupropion in elderly patients with major depressive disorder. *J Psychopharmacol.* 2010;24(4):521-9.
91. Tedeschini E, Levkovitz Y, Iovieno N, Ameral VE, Nelson JC, Papakostas GI. Efficacy of antidepressants for late-life depression: a meta-analysis and meta-regression of placebo-controlled randomized trials. *J Clin Psychiatry.* 2011;72(12):1660-8.
92. Corp SA, Gitlin MJ, Altshuler LL. A review of the use of stimulants and stimulant alternatives in treating bipolar depression and major depressive disorder. *J Clin Psychiatry.* 2014;75(9):1010-8.
93. Kales HC, Kim HM, Zivin K, Valenstein M, Seyfried LS, Chiang C, et al. Risk of mortality among individual antipsychotics in patients with dementia. *Am J Psychiatry.* 2012;169(1):71-9.
94. Maust DT, Kim HM, Seyfried LS, Chiang C, Kavanagh J, Schneider LS, et al. Antipsychotics, other psychotropics, and the risk of death in patients with dementia: number needed to harm. *JAMA.* 2015;72(5):438-45.

95. D'Souza R, Rajji TK, Mulsant BH, Pollock BG. Use of lithium in the treatment of bipolar disorder in late-life. *Curr Psychiatry Rep*. 2011;13(6):488-92.
96. Kang DY, Park S, Rhee CW, Kim YJ, Choi NK, Lee J, et al. Zolpidem use and risk of fracture in elderly insomnia patients. *J Prev Med Public Health*. 2012;45(4):219-26.
97. [Livertox.nlm](https://livertox.nlm.nih.gov/) [Internet]. LiverTox. Bethesda: NLM; c2017 [capturado em 27 jan. 2017]. Disponível em: <https://livertox.nlm.nih.gov/>.
98. Crone CC, Gabriel GM, DiMartini A. An overview of psychiatric issues in liver disease for the consultation-liaison psychiatrist. *Psychosomatics*. 2006;47(3):188-205.
99. Crone CC, Dobbelsstein CR. Gastrointestinal disorders. In: In: Levenson JL, editor. *The American Psychiatric Publishing textbook of psychosomatic medicine: psychiatric care of the medically ill*. 2nd ed. Washington: APA; 2011. p. 463-90.
100. Crone CC, Gabriel GM. Treatment of anxiety and depression in transplant patients: pharmacokinetic considerations. *Clin Pharmacokinet*. 2004;43(6):361-94.
101. Cruz MP. Lurasidone HCl (Latuda), an oral, once-daily atypical antipsychotic agent for the treatment of patients with schizophrenia. *P T*. 2011;36(8):489-92.
102. Schlatter C, Egger SS, Tchambaz L, Krahenbuhl S. Pharmacokinetic changes of psychotropic drugs in patients with liver disease: implications for dose adaptation. *Drug Saf*. 2009;32(7):561-78.
103. Baldwin DS, Chrones L, Florea I, Nielsen R, Nomikos GG, Palo W, et al. The safety and tolerability of vortioxetine: analysis of data from randomized placebo-controlled trials and open-label extension studies. *J Psychopharmacol*. 2016;30(3):242-52.
104. Kelliny M, Croarkin PE, Moore KM, Bobo WV. Profile of vortioxetine in the treatment of major depressive disorder: an overview of the primary and secondary literature. *Ther Clin Risk Manag*. 2015;11:1193-212.
105. Vuppalanchi R, Hayashi P, Chalasani N, Fontana RJ, Bonkovsky H, Saxena R, et al. Duloxetine hepatotoxicity: a case-series from the drug-induced liver injury network. *Aliment Pharmacol Ther*. 2010;32(9):1174-83.
106. Kang S-G, Park Y-M, Lee H-J, Yoon B. Duloxetine-induced liver injury in patients with major depressive disorder. *Psychiatry Investig*. 2011;8(3):269-71.
107. Gahr M, Freudenmann RW, Connemann BJ, Hiemke C, Schonfeldt-Lecuona C. Agomelatine and hepatotoxicity: implications of cumulated data derived from spontaneous reports of adverse drug reactions. *Pharmacopsychiatry*. 2013;46(6):214-20.
108. Montastruc F, Scotto S, Vaz IR, Guerra LN, Escudero A, Sainz M, et al. Hepatotoxicity related to agomelatine and other new antidepressants: a case/noncase approach with information from the Portuguese, French, Spanish, and Italian pharmacovigilance systems. *J Clin Psychopharmacol*. 2014;34(3):327-30.
109. Boinpally R, Henry D, Gupta S, Edwards J, Longstreth J, Periclou A. Pharmacokinetics and safety of vilazodone in hepatic impairment. *Am J Ther*. 2015;22(4):269-77.
110. Cohen LM, Tessier EG, Germain MJ, Levy NB. Update on psychotropic medication use in renal disease. *Psychosomatics*. 2004;45(1):34-48.

111. Vermeir M, Naessens I, Remmerie B, Mannens G, Hendrickx J, Sterkens P, et al. Absorption, metabolism, and excretion of paliperidone, a new monoaminergic antagonist, in humans. *Drug Metab Dispos.* 2008;36(4):769-79.
112. Cukor D, Rosenthal-Asher D, Cohen LM, Levenson J, Kimmel PL. Renal disease In: Levenson J, editor. *The American Psychiatric publishing textbook of psychosomatic medicine psychiatric care of the medically III*. 2nd ed. Washington: APA; 2011. p. 1200.
113. Heykants J, Huang ML, Mannens G, Meuldermans W, Snoeck E, Van Beijsterveldt L, et al. The pharmacokinetics of risperidone in humans: a summary. *J Clin Psychiatry.* 1994;55 Suppl:13-7.
114. Thyrum PT, Wong YW, Yeh C. Single-dose pharmacokinetics of quetiapine in subjects with renal or hepatic impairment. *Prog Neuropsychopharmacol Biol Psychiatry.* 2000;24(4):521-33.
115. Peeters P, Bockbrader H, Spaans E, Dogterom P, Lasseter K, Marbury T, et al. Asenapine pharmacokinetics in hepatic and renal impairment. *Clin Pharmacokinet.* 2011;50(7):471-81.
116. Cohen SD, Norris L, Acquaviva K, Peterson RA, Kimmel PL. Screening, diagnosis, and treatment of depression in patients with end-stage renal disease. *Clin J Am Soc Nephrol.* 2007;2(6):1332-42.
117. Troy SM, Schultz RW, Parker VD, Chiang ST, Blum RA. The effect of renal disease on the disposition of venlafaxine. *Clin Pharmacol Ther.* 1994;56(1):14-21.
118. Lobo ED, Heathman M, Kuan H-Y, Reddy S, O'Brien L, Gonzales C, et al. Effects of varying degrees of renal impairment on the pharmacokinetics of duloxetine. *Clin Pharmacokinet.* 2010;49(5):311-21.
119. Boipally R, Alcorn H, Adams MH, Longstreth J, Edwards J. Pharmacokinetics of vilazodone in patients with mild or moderate renal impairment. *Clin Drug Investig.* 2013;33(3):199-206.
120. Baldwin DS, Chrones L, Florea I, Nielsen R, Nomikos GG, Palo W, et al. The safety and tolerability of vortioxetine: analysis of data from randomized placebo-controlled trials and open-label extension studies. *J Psychopharmacol.* 2016;30(3):242-52.
121. Breidenbach T, Hoffmann MW, Becker T, Schlitt H, Klempnauer J. Drug interaction of St John's wort with cyclosporin. *Lancet.* 2000;355(9218):1912.
122. Lacerda G, Krummel T, Sabourdy C, Ryvlin P, Hirsch E. Optimizing therapy of seizures in patients with renal or hepatic dysfunction. *Neurology.* 2006;67(12 Suppl 4):S28-33.
123. Winkelmayer WC, Mehta J, Wang PS. Benzodiazepine use and mortality of incident dialysis patients in the United States. *Kidney Int.* 2007;72(11):1388-93.
124. Sachs HC; Committee On Drugs. The transfer of drugs and therapeutics into human breast milk: an update on selected topics. *Pediatrics.* 2013;132(3):e796-809.
125. Uguz F. Second-generation antipsychotics during the lactation period: a comparative systematic review on infant safety. *J Clin Psychopharmacol.* 2016;36(3):244-52.
126. Uguz F, Sharma V. Mood stabilizers during breastfeeding: a systematic review of the recent literature. *Bipolar Disord.* 2016;18(4):325-33.

127. Kelly LE, Poon S, Madadi P, Koren G. Neonatal benzodiazepines exposure during breastfeeding. *J Pediatr*. 2012;161(3):448-51.
128. Payne JL, Meltzer-Brody S. Antidepressant use during pregnancy: current controversies and treatment strategies. *Clin Obstet Gynecol*. 2009;52(3):469-82.
129. Ballard C, Isaacson S, Mills R, Williams H, Corbett A, Coate B, et al. Impact of current antipsychotic medications on comparative mortality and adverse events in people with Parkinson disease psychosis. *J Am Med Dir Assoc* 2015;16(10):898.
130. Frieling H, Hillemacher T, Ziegenbein M, Neundörfer B, Bleich S. Treating dopaminergic psychosis in Parkinson's disease: structured review and meta-analysis. *Eur Neuropsychopharmacol*. 2007;17(3):165-71.
131. Liu J, Dong J, Wang L, Su Y, Yan P, Sun S. Comparative efficacy and acceptability of antidepressants in parkinson's disease: a network meta-analysis. *PLoS One*. 2013;8(10):e76651.
132. Avila A, Cardona X, Martin-Baranera M, Leon L, Caballol N, Millet P, et al. Agomelatine for depression in Parkinson disease: additional effect on sleep and motor dysfunction. *J Clin Psychopharmacol*. 2015;35(6):719-23.
133. De Berardis D, Fornaro M, Serroni N, Olivieri L, Marini S, Moschetta FS, et al. Agomelatine treatment of major depressive disorder in Parkinson's disease: a case series. *J Neuropsychiatry Clin Neurosci*. 2013;25(4):343-5.
134. Loane C, Politis M. Buspirone: what is it all about? *Brain Res*. 2012;1461:111-8.
135. Moro-de-Casillas ML, Riley DE. Insomnia in parkinson's disease. In: Pfeiffer RF, Bodis-Wollner I, editors. *Parkinson's disease and nonmotor dysfunction*. Humana Press; 2013. p. 245-55.
136. Maier F, Merkl J, Ellereit AL, Lewis CJ, Eggers C, Pedrosa DJ, et al. Hypomania and mania related to dopamine replacement therapy in Parkinson's disease. *Parkinsonism Relat Disord*. 2014;20(4):421-7.
137. Meriç C, Pirdogan E, Toker G, Tekin A, Bakim B, Celik S. Mania with psychotic feature induced by the use of pramipexole in Parkinson's disease: a case report. *Turk Psikiyatri Dergisi*. 2014;25(3):212.
138. Chopra A, Tye SJ, Lee KH, Sampson S, Matsumoto J, Adams A, et al. Underlying neurobiology and clinical correlates of mania status after subthalamic nucleus deep brain stimulation in Parkinson's disease: a review of the literature. *J Neuropsychiatry Clin Neurosci*. 2012;24(1):102-10.
139. Forlenza OV, Caramelli P. *Neuropsiquiatria geriátrica*. São Paulo: Atheneu; 2000.
140. Elbers RG, Berendse HW, Kwakkel G. Treatment of fatigue in Parkinson disease. *JAMA*. 2016;315(21):2340-1.
141. Moreau C, Delval A, Defebvre L, Dujardin K, Duhamel A, Petyt G, et al. Methylphenidate for gait hypokinesia and freezing in patients with Parkinson's disease undergoing subthalamic stimulation: a multicentre, parallel, randomised, placebo-controlled trial. *Lancet Neurol*. 2012;11(7):589-96.

142. Kehagia AA, Housden CR, Regenthal R, Barker RA, Müller U, Rowe J, et al. Targeting impulsivity in parkinson's disease using atomoxetine. *Brain*. 2014;137(Pt 7):1986-97.
143. Wang H-F, Yu J-T, Tang S-W, Jiang T, Tan C-C, Meng X-F, et al. Efficacy and safety of cholinesterase inhibitors and memantine in cognitive impairment in Parkinson's disease, Parkinson's disease dementia, and dementia with lewy bodies: systematic review with meta-analysis and trial sequential analysis. *J Neurol Neurosurg Psychiatry*. 2015;86(2):135-43.
-

[habitual] Com exceção de cesariana, se a parturiente tiver a intenção de amamentar o bebê.

[via oral] Em outros países, há, por exemplo, opções de uso intravenoso para lorazepam, citalopram e valproato; de uso retal para diazepam e proclorperazina (um antipsicótico); e de uso intramuscular para aripirazol, olanzapina, risperidona e ziprasidona. Há, também, opções de uso transdérmico e intranasal para alguns psicofármacos. O Instituto Lundbeck, na Dinamarca, disponibiliza uma base de dados com as várias formulações disponíveis em diversos países.⁴⁹

[50mL/min] Informação fornecida pelo fabricante.



Psicofármacos: reações adversas e intoxicações

Amilton dos Santos Júnior
Luiz Fernando de Almeida Lima e Silva
Luiz Fernando Paulin

O médico deve considerar algumas precauções nas prescrições de psicofármacos, não perdendo de vista que a medicação é mais um, e não o único, instrumento de um processo amplo, inesgotável e terapêutico, que é a relação médico-paciente. Além de considerar as reações adversas possíveis de cada psicofármaco, este capítulo se ocupa do diagnóstico e do tratamento de quadros toxicológicos com particular relevância para a prática psiquiátrica. Alguns pacientes fazem ingestão, intencional ou acidental, de venenos, como organofosforados e carbamato (“chumbinho”). O quadro clínico e o tratamento da intoxicação por essas substâncias também são aqui abordados.

ANTIPSICÓTICOS

Desde seu surgimento, no início da década de 1950, os antipsicóticos, também chamados de neurolépticos, vêm revolucionando o tratamento e melhorando a evolução dos pacientes psicóticos, viabilizando o acompanhamento ambulatorial e diminuindo a necessidade e a duração de internações psiquiátricas.

Muitos antipsicóticos atuam bloqueando a ação da dopamina, portanto, é importante conhecer as vias dopaminérgicas do sistema nervoso central (SNC). Esse conhecimento é essencial para a compreensão da ação terapêutica e de algumas reações adversas dos diferentes tipos de antipsicóticos.

Os antipsicóticos são divididos em dois grupos principais:¹

- Típicos ou de primeira geração: apresentam ação bloqueadora principalmente em neurônios dopaminérgicos D2, com probabilidade de desenvolvimento de efeitos extrapiramidais, discinesia tardia e aumento da prolactina sérica. Além disso, têm maior ou menor ação em outros sítios receptores. Podem ser subdivididos nas categorias dos incisivos (haloperidol, flufenazina, penfluridol, pimozida, pipotiazina e zuclopentixol), com ação antipsicótica mais potente, e dos sedativos (clorpromazina, levomepromazina e trifluoperazina), indicados para casos com agitação psicomotora.
- Atípicos ou de segunda geração: têm menos efeitos extrapiramidais, discinesia tardia e alterações da prolactina sérica, devido à menor afinidade pelos receptores dopaminérgicos D2. Também agem em outros receptores dopaminérgicos e em outros sistemas de neurotransmissores, sendo potentes bloqueadores serotoninérgicos (5-HT₂). Os principais antipsicóticos atípicos disponíveis no Brasil são clozapina, olanzapina, quetiapina, risperidona, paliperidona, ziprasidona e aripiprazol.

Reações adversas

Distonia aguda

Provocada possivelmente por alterações da atividade dopaminérgica nos gânglios da base, pode ser induzida por antipsicóticos e outros agentes antidopaminérgicos. O quadro clínico inclui contrações musculares tônicas dolorosas, que atingem principalmente os músculos do pescoço, a mandíbula, a língua e a face. Podem ocorrer também crises oculogíricas e opistótonas, sendo tal ocorrência mais comum no início do tratamento, em indivíduos que fazem uso de antipsicóticos de alta potência em altas doses e com história de distonia aguda. Para o manejo de agitação psicomotora de pacientes que necessitam receber doses intramusculares de haloperidol, o risco de distonia parece ser menor com a administração conjunta de prometazina intramuscular. As principais medidas a serem tomadas em casos de distonia encontram-se no Quadro 25.1.

QUADRO 25.1

Diretrizes para o tratamento da distonia aguda

- Antiparkinsonianos: biperideno, preferencialmente por via parenteral (intramuscular [IM] ou intravenosa lenta [IV]). Aplicar 2 mg por dose, repetindo em intervalos de 30 minutos, caso não haja melhora do sintoma. Não aplicar mais de 4 doses em 24 horas. Triexafenidil, 1 mg, em dose única. Caso as manifestações não sejam controladas em poucas horas, aumentar progressivamente a dose até a obtenção de resultados satisfatórios. Em geral, usam-se entre 5 e 10 mg.
- Alguns serviços não têm o biperideno padronizado para uso parenteral; nesse caso, ele pode ser substituído por prometazina, 25 mg, IM.
- Não ocorrendo melhora, deve-se utilizar diazepam, 10 mg, VO ou IV lenta.
- Distonia laringea apresenta risco de óbito. Nesse caso, aplicar biperideno, 2 mg, IV. Não havendo resposta em 5 a 10 minutos, repetir a dose.

Atenção: Um fato não raro em serviços de emergência é o atendimento de pessoas que usam anticolinérgicos de forma abusiva, devido à sensação de euforia que essas substâncias podem causar, semelhante à de anfetaminas. Tal situação pode ser observada em pacientes que simulam crises repetidas de distonia aguda ou de parkinsonismo, procurando o serviço com regularidade.²

Parkinsonismo (“impregnação”)

O quadro clínico de parkinsonismo inclui bradicinesia, rigidez muscular, sinal da roda denteada, fácies em máscara (hipomímia), hipersalivação, tremores finos de extremidades, postura encurvada, marcha em bloco, sensação de estar em uma “camisa de força”. O quadro surge no início do tratamento com antipsicóticos, principalmente com os de alta potência. No entanto, pode ocorrer também com outras classes de psicofármacos. Há maior incidência em idosos.

- *Etiologia:* bloqueio da transmissão dopaminérgica (D2) no sistema nigroestriatal.
- *Diagnóstico diferencial:* Parkinson idiopático, catatonia, esquizofrenia com predomínio de sintomas negativos, depressão pós-esquizofrênica.
- *Tratamento:* biperideno, 2 mg, via oral (VO), podendo chegar a 8 mg/dia. Recomenda-se a redução da dose do antipsicótico ou sua substituição por outro de baixa potência ou atípico.

Atenção: Um fenômeno pouco conhecido é o desenvolvimento de tolerância aos efeitos parkinsonianos. Após cerca de 20 dias do início do tratamento com um medicamento antiparkinsoniano, deve-se diminuir a dose gradualmente até sua retirada, para avaliar se ainda há sintomas de impregnação.

Acatisia

O quadro clínico de acatisia apresenta-se com sensação subjetiva de inquietação motora, ansiedade, impossibilidade de permanecer imóvel, sentado ou em pé. Pode haver alteração do sono por dificuldade em permanecer deitado.

O tratamento deve consistir em diminuir a dose ou trocar o antipsicótico. Uma alternativa é introduzir um benzodiazepínico (clonazepam, 1-2 mg/dia; diazepam, 10-30 mg/dia). O betabloqueador propranolol, em doses de 30 a 90 mg/dia, também está indicado. Anticolinérgicos, no entanto, não apresentam resposta satisfatória.

Atenção ao diagnóstico diferencial: um quadro clínico de menor gravidade pode ser equivocadamente diagnosticado como ansiedade, e quadros mais graves, como agitação

psicótica. A dificuldade em diferenciar esses dois quadros pode levar o profissional a aumentar a dose do antipsicótico, piorando a sintomatologia.

Síndrome neuroléptica maligna (SNM)

O quadro clínico apresenta-se com rigidez muscular grave, febre, alterações autonômicas, taquipneia, diaforese e alterações do nível de consciência, podendo ocorrer um quadro de *delirium*. Com incidência de 0,7%, a síndrome neuroléptica maligna pode ocorrer com todos os antipsicóticos, inclusive os atípicos, embora em menor proporção.³

Quanto à etiologia, supõe-se que a SNM ocorra pelo distúrbio da termorregulação, devido ao bloqueio dopaminérgico provocado pelos antipsicóticos no hipotálamo e nos gânglios da base.

A mortalidade pode chegar a 21%, tendo como causas mais frequentes distúrbios cardiovasculares, embolia pulmonar, pneumonia aspirativa e insuficiência renal.

Os fatores de risco são: sexo masculino; transtorno mental orgânico ou do humor; uso concomitante de lítio; desidratação (atenção: esse é o principal fator de risco identificado!). Os clínicos devem estar vigilantes quanto à ocorrência de SNM entre pacientes agitados ou em *delirium* atendidos em unidades de emergência.³

Os exames laboratoriais apresentam creatinínofosfoquinase aumentada (alta sensibilidade e baixa especificidade). Cerca de 40% dos pacientes têm leucocitose com desvio à esquerda. Provas de função hepática também podem estar alteradas.

As principais medidas de tratamento encontram-se no Quadro 25.2.

QUADRO 25.2

Tratamento da síndrome neuroléptica maligna

- Interromper o uso de antipsicótico.
- Medidas de suporte: hidratação, controle hidreletrolítico e monitoramento cardíaco, respiratório e renal. O uso de antitérmicos para tratamento da febre alta é primordial.
- Agonista dopaminérgico: bromocriptina, 2,5 mg, VO, 3 vezes ao dia, podendo chegar a 40 mg/dia. Essa medicação proporciona alívio da rigidez e de outros sintomas do bloqueio dopaminérgico.
- Relaxante muscular de ação periférica: dantroleno, 0,8-1,0 mg/kg, IV, a cada 6 horas.
- Benzodiazepínicos: diazepam, 10 mg, IV, até 40 mg/dia, em caso de agitação.
- Anticolinérgicos são contraindicados, pois podem agravar a hipertermia e precipitar *delirium*.³

Atenção: lembrar que alguns pacientes fazem uso de neurolépticos de depósito.

Caso seja necessário reintroduzir o antipsicótico, aguardar, pelo menos, duas semanas após a interrupção e optar por um atípico.

Atenção: Segundo Gomes e colaboradores,³ “Nem toda rigidez provocada por neurolépticos é parkinsonismo e nem toda SNM é febril”. Os autores relataram o caso de uma paciente atendida pela equipe de emergência clínica do Hospital das Clínicas da Unicamp, com SNM, cujo diagnóstico foi inicialmente prejudicado pela ausência de febre, embora os demais sintomas, sinais e alterações laboratoriais estivessem presentes.³ A hipótese inicial havia sido de impregnação, diante da rigidez apresentada após início de uso de clorpromazina, 300 mg/dia, prescrita em outro serviço. A administração subsequente do anticolinérgico biperideno prejudicou o diagnóstico e precipitou *delirium* quando a equipe de emergência/interconsulta

psiquiátrica foi acionada. Houve melhora clínica após suspensão de ambas medicações e instalação de medidas de suporte.³

Discinesia tardia

Discinesia tardia é uma síndrome de surgimento tardio devida ao uso prolongado de anti-psicóticos que raramente se apresenta antes de seis meses de tratamento.⁴ A prevalência é de 20 a 25% dos pacientes que usam antipsicóticos, e a incidência é de cerca de 5% ao ano, sendo maior em idosos.⁴

O quadro clínico inclui movimentos involuntários de lábios, língua e mandíbula, podendo ocorrer movimentos coreiformes ou atetoides de extremidades e tronco. Estes podem ser leves e sutis ou incapacitantes e desfigurantes. Observa-se aumento desses movimentos em situações de ansiedade e desaparecimento durante o sono.

Os fatores de risco para essa síndrome são: idade avançada, sexo feminino, exposição prolongada ao antipsicótico, associação ao lítio, transtorno do humor e presença de lesão orgânica cerebral. Porém, a etiologia é desconhecida. Suspeita-se que o bloqueio crônico dopaminérgico nos gânglios da base leve a um aumento de sítios de receptores.

Não existe tratamento seguro e efetivo. Quando possível, deve-se diminuir a dose do antipsicótico ou substituí-lo por atípicos.⁴ Outras propostas incluem agonistas alfa-1-adrenérgicos (clonidina 0,1-0,8 mg/dia), betabloqueadores (propranolol 30-120 mg/dia) ou benzodiazepínicos (clonazepam 2-6 mg/dia).⁵

Atenção: Antiparkinsonianos, por serem antagonistas da dopamina no estriado, pioram temporariamente a discinesia tardia; portanto, sua utilização deve ser evitada.

Convulsões

Diversos antipsicóticos reduzem o limiar para a ocorrência de convulsões, particularmente a clorpromazina e a clozapina, sendo as chances de ocorrência dose-dependentes. Doses maiores que 550 a 600 mg/dia de clozapina podem requerer o uso concomitante de terapia anticonvulsivante, de preferência com ácido valproico.^{6,7}

Efeitos cardiovasculares

Hipotensão postural: ocorre principalmente com antipsicóticos sedativos (clorpromazina, tioridazina), devido ao bloqueio alfa-adrenérgico, e também com clozapina e quetiapina.⁷ Os sintomas surgem nos primeiros dias de tratamento, com posterior tolerância. O paciente deve ser orientado a se levantar vagarosamente.

Arritmias: muitos psicofármacos podem causar alterações nas propriedades elétricas das células cardíacas, manifestadas clinicamente por bloqueios atrioventriculares e de ramo ou prolongamento do intervalo QT (ver Quadro 25.3). Ziprasidona, tioridazina e pimozida podem prolongar o intervalo QT, desencadeando taquicardia ventricular. Se o paciente apresentar alterações prévias de condução cardíaca, deve-se evitar prescrever esses medicamentos.⁷

QUADRO 25.3

Psicofármacos associados a prolongamento de QT e/ou *torsades de pointes*

■ Amitriptilina	■ Lítio
■ Amoxapina	■ Maprotilina
■ Clorpromazina	■ Nortriptilina
■ Clomipramina	■ Pimozida
■ Desipramina	■ Protriptilina
■ Doxepina	■ Risperidona
■ Droperidol	■ Tioridazina
■ Flufenazina	■ Tiotixeno
■ Haloperidol	■ Trifluoperazina
■ Imipramina	■ Ziprasidona

Fonte: Com base em Costa e Gonçalves.¹⁰

Há uma advertência formal da Food and Drug Administration (FDA) sobre casos de morte súbita, prolongamento do intervalo QT e *torsades de pointes* em pacientes tratados com haloperidol, especialmente em administrações intravenosas ou em doses maiores do que a recomendada. Ainda que o haloperidol injetável esteja aprovado pela FDA apenas para injeção intramuscular, há evidências de que a administração intravenosa seja relativamente comum na prática clínica.⁸

Efeitos hematológicos

Antipsicóticos típicos raramente provocam leucopenia. Quando ocorre, é transitória e sem repercussão clínica.

Mortes decorrentes da associação entre clozapina e agranulocitose foram relatadas na década de 1970. Em 1990, esse fármaco foi relançado no mercado para uso em pacientes resistentes ao tratamento com antipsicóticos convencionais.

Devido à incidência de neutropenia em 3 a 4% dos pacientes, e de agranulocitose, em 0,8%, cuidados hematológicos devem ser seguidos.⁹ A indicação da clozapina deve ser acompanhada de hemogramas semanais, por um período de 18 semanas, e, então, mensalmente. Se o tratamento for descontinuado por mais de 48 horas, deverá ser reiniciado com doses de 12,5 a 25 mg/dia, gradualmente aumentadas e com controle de hemograma.^{6,7}

Caso o leucograma esteja menor do que 2.000 leucócitos, e/ou a contagem de granulócitos, abaixo de 1.000, a clozapina deve ser imediatamente descontinuada, o mesmo a fazer se a eosinofilia for maior do que 4.000.⁹ Após 2 a 4 semanas de interrupção da clozapina, o leucograma tende a voltar à normalidade.

Efeitos endocrinológicos

Efeitos endocrinológicos estão associados ao bloqueio dopaminérgico no sistema neuro-hipofisário. As alterações mais comuns são amenorreia ou atraso menstrual, galactorreia (principalmente com risperidona, sulpirida e amissulpirida) e disfunções sexuais, como diminuição da libido, anorgasmia, impotência e retardo na ejaculação. Clorpromazina,

tioridazina, quetiapina, clozapina e olanzapina podem provocar ganho de peso, hiperlipidemias e mudanças no metabolismo da glicose, com possível ocorrência de diabetes. Tais riscos são praticamente inexistentes em relação a ziprasidona e aripiprazol. Devem-se orientar dietas hipocalóricas e atividade física. Se necessário, trocar medicamentos ou solicitar avaliação endocrinológica (ver Quadro 25.4).

QUADRO 25.4

Efeitos adversos endocrinológicos de psicofármacos

Medicamentos	Efeitos adversos
Antidepressivos ■ ISRSs ou ISRNs ■ Tricíclicos	Hiperprolactinemia, hipoglicemia (raro), hipotireoidismo (raro) Hiperpicemia, hiperprolactinemia
Antipsicóticos ■ Atípicos e típicos	Hiperpicemia, hiperprolactinemia, hipogonadismo
Estabilizadores do humor ■ Lítio ■ Carbamazepina ■ Ácido valproico	Hipotireoidismo, hipertireoidismo, diabetes insípido nefrogênico Hipotireoidismo, diminuição de FSH e LH, hipogonadismo Hipotireoidismo, diminuição de FSH e LH, hiperandrogenismo (mulheres)

ISRSs, inibidores seletivos da recaptação de serotonina; ISRNs, inibidores seletivos da recaptação de serotonina e noradrenalina; FSH, hormônio estimulante de folículo; LH, hormônio luteinizante.

Fonte: Com base em Ferrando e colaboradores.¹⁴

Intoxicação

Intoxicação é uma situação rara, ocorrendo principalmente como tentativa de suicídio. Os antipsicóticos têm pequeno potencial letal, exceto em associação com outros depressores do SNC, como álcool e benzodiazepínicos. Bases do tratamento são descritas no Quadro 25.5.

QUADRO 25.5

Tratamento da intoxicação por antipsicóticos

- Lavagem gástrica quando o tempo de ingestão for inferior a 6 horas. Evitar o uso de eméticos, devido à ação antiemética dos antipsicóticos.
- Carvão ativado.
- Hipotensão arterial: expansor de volume. Caso não ocorra melhora, introduzir vasopressores como noradrenalina ou dopamina.
- Adrenalina deve ser evitada.
- Febre alta: antipiréticos.
- Efeitos extrapiramidais: biperideno IM ou IV.
- Arritmias cardíacas: isoproterenol.
- Diurese forçada ou diálise não têm utilidade.

ANTIDEPRESSIVOS

Inibidores seletivos da recaptação de serotonina (ISRSs)

Tendo surgido nos anos de 1980, o grupo de ISRSs representou grande evolução, devido a sua eficácia terapêutica e aos efeitos adversos menos significativos, quando comparados aos de antidepressivos tricíclicos (ADTs) e inibidores da monoaminoxidase (IMAOs). Incluem fluoxetina, paroxetina, fluvoxamina, sertralina, citalopram e escitalopram.

O mecanismo de ação dos ISRSs se dá por meio da inibição seletiva na recaptação da neurotransmissão serotoninérgica. Apesar do mecanismo de ação semelhante, os ISRSs são estruturalmente distintos quanto ao perfil farmacocinético e farmacodinâmico.^{7,11} Um dado que diferencia esses fármacos são as ações anticolinérgica, anti-histamínica e antialfa-adrenérgica quase inexistentes, com menos efeitos adversos que os ADTs.¹²

Reações adversas

Sistema nervoso central

Agitação psicomotora e aumento da ansiedade surgem em até 15% dos pacientes nos primeiros dias de uso de antidepressivos, com possível descontinuidade do tratamento. Uma alternativa é iniciar o tratamento com doses menores do que as preconizadas e aumentos graduais.

Pode ocorrer ciclagem maníaca, principalmente com a fluoxetina. Na vigência de um episódio depressivo em pacientes com transtorno bipolar, no qual haja necessidade de uso de antidepressivos, deve-se evitar prescrevê-lo sem o uso concomitante de um estabilizador do humor e priorizar o uso da bupropiona.

Insônia ocorre em 14% dos pacientes em uso de fluoxetina; portanto, recomenda-se prescrição pela manhã.

Síndrome serotoninérgica

A síndrome serotoninérgica é um quadro grave e pouco diagnosticado em serviços de emergência. Caracteriza-se por uma reação tóxica, resultante da superestimulação de receptores do tipo 5-HT no tronco cerebral e na medula espinal. Essa síndrome ocorre principalmente quando há associação com antidepressivos com ação serotoninérgica (mais de um ISRS; ISRS e IMAO; ISRS e ADT; e IMAO e ADT). O risco é maior em idosos e em hepatopatas.¹¹ Os sintomas são descritos no Quadro 25.6. A melhora costuma ser rápida, após a retirada imediata das substâncias que causam o quadro, com monitoramento e tratamento de suporte.

QUADRO 25.6

Sintomas da síndrome serotoninérgica

Mentais	Confusão, inquietação, agitação, ansiedade, sintomas maníacos, redução do nível de consciência
Neuromusculares, neurológicos	Tremor, rigidez, clono, mioclonia, hiper-reflexia, ataxia
Autônômicos	Sudorese, tremores, midríase, náusea, diarreia

Uma senhora de 69 anos com história de depressão, parcialmente responsiva a paroxetina (40 mg/dia), teve a dose aumentada para 60 mg/dia. Duas semanas depois, foram introduzidas buspirona, 5 mg, a cada 8 horas, e trazodona, 100 mg, à noite, para manejo de insônia. Ela teve confusão, sudorese, febre, hiper-reflexia e discreta rigidez muscular, sendo levada ao hospital. Foi feito o diagnóstico de síndrome serotoninérgica. A paroxetina e a buspirona foram descontinuadas, sendo instituídas medidas de suporte, com melhora do quadro em dois dias.¹³

Sangramento gastrointestinal

A relação entre os ISRSs e o aumento do risco de sangramento gastrointestinal já foi comprovada por diversos autores.^{17,18} A liberação de serotonina do interior das plaquetas promove sua agregação, uma etapa importante no processo de coagulação. Por não haver produção de serotonina no interior das plaquetas, sua captação é necessária a partir do plasma, para que os níveis intravasculares adequados sejam atingidos. Como os ISRSs impedem a recaptação da serotonina das plaquetas, são capazes de inibir o processo de agregação. A dimensão desse efeito em indivíduos sadios é semelhante à dos anti-inflamatórios não esteroidais (AINEs) em doses baixas. O risco, entretanto, é consideravelmente maior em indivíduos com fatores de risco de sangramento gastrointestinal: plaquetopenia, doenças da coagulação e uso contínuo de AINEs.¹⁷

O uso de antidepressivos também deve ser muito cuidadoso nos pacientes que fazem uso de varfarina. O risco de sangramento é maior, pelo efeito direto desses medicamentos no processo de coagulação e pela inibição do metabolismo do anticoagulante. Sertralina e citalopram parecem ser os mais seguros, enquanto fluvoxamina e fluoxetina são os que mais aumentam o risco de sangramento.¹⁹

Outros efeitos gastrintestinais

Náuseas, vômitos, dispepsia, cólicas abdominais e diarreia podem surgir no início do tratamento. A náusea é a reação adversa mais comum, com posterior tolerância. A paroxetina parece ter afinidade de ligação para os receptores colinérgicos muscarínicos equivalente à nortriptilina, produzindo efeitos anticolinérgicos dose-dependentes. Esse fato justifica quadros de constipação intestinal. Para o manejo, aguarda-se o tempo de adaptação do organismo ou se reduz a dose temporariamente, com posterior aumento gradual.

Alterações do peso

Apesar de a maioria dos pacientes que inicia uso de ISRSs perder peso, o contrário pode ocorrer em até um terço, com o uso prolongado. A fluoxetina é usada como inibidor do apetite, porém tal função vem sendo questionada. Citalopram e paroxetina são os que provocam maior ganho de peso.

Disfunção sexual

Ocorre disfunção sexual em 16,3 a 75% dos pacientes. Diminuição da libido é o efeito mais relatado, acompanhado de anorgasmia, ejaculação retardada e impotência. Ver o Quadro 25.14

para estratégias de manejo.

Síndrome de abstinência

A síndrome de abstinência é uma situação clínica que ocorre em pacientes com uso prolongado de alguns antidepressivos, quando há interrupção abrupta da medicação. A retirada de qualquer ISRS pode provocar o quadro. Tipicamente, os sintomas surgem alguns dias após a última administração, duram poucas semanas e ocorrem quando há redução rápida da dose, esquecimento de tomadas ou interrupção súbita da medicação. Mais raramente, os sintomas podem também ocorrer após interrupção lenta, surgir tardiamente ou, ainda, durar períodos mais longos.¹⁶ A paroxetina é o ISRS que provoca maior efeito de abstinência, seguida de citalopram, sertralina, fluvoxamina e, por último, fluoxetina. Os sintomas e o tratamento são descritos no Quadro 25.7.

QUADRO 25.7

Sintomas da síndrome de abstinência de fármacos com ações serotoninérgicas

Neuropsiquiátricos	Tonturas, instabilidade da marcha, parestesias, sensações de choque, alterações visuais, dificuldade de concentração
Emocionais	Insônia, pesadelos, irritabilidade, agitação, alterações do humor (depressão, ansiedade, sintomas maníacos)
Físicos	Náusea, diarreia, cefaleia, fadiga, mialgia

Manejo: a reintrodução do fármaco em geral faz os sintomas desaparecerem. Em tentativas subsequentes de interrupção do fármaco, devem ser tentadas reduções mais lentas e graduais das doses (redução de um quarto da dose por semana). O paciente também deve ser orientado a não interromper o uso de forma abrupta.

Fonte: Looper¹⁵ e Fava e colaboradores.¹⁶

Outros efeitos

Mioclonias e fasciculações (principalmente com o uso de paroxetina), hiponatremia, parkinsonismo, farmacodermias e alterações hormonais (ver Quadros 25.4 e 25.15) podem ser citadas. Síndrome da secreção inapropriada de hormônio antidiurético (ADH) é uma complicação rara (ver Quadros 25.13 e 25.15).

Intoxicação

Os ISRSs são mais seguros do que os outros antidepressivos em superdoses, em especial quando tomados isoladamente. O quadro clínico apresenta-se da seguinte maneira: agitação psicomotora, insônia, tremores, náusea, vômitos, taquicardia e, raramente, convulsões. Há diminuição do nível de consciência, e alterações do eletrocardiograma (ECG) surgem apenas em doses extremamente altas, cerca de 75 vezes a dose terapêutica.^{7,9,11}

O tratamento deve ser feito por meio de lavagem gástrica e indução do vômito, sendo necessária a observação dos sinais vitais. Caso a intoxicação seja por fluoxetina, deve-se manter o paciente em observação por um período de 24 a 48 horas, devido à meia-vida longa.

Antidepressivos tricíclicos (ADTs)

Os ADTs conformam um grupo que causa várias reações adversas. Seu índice terapêutico é baixo, o que os caracteriza como potencialmente letais. Devem ser evitados em idosos e crianças e *não* devem ser prescritos quando se considera que o risco de suicídio é elevado.¹²

O mecanismo de ação desses fármacos ocorre da seguinte maneira: bloqueio neuronal pré-sináptico da recaptação de aminas biogênicas e potente antagonismo em receptores colinérgicos muscarínicos, histaminérgicos e alfa-1-adrenérgicos.^{7,9,11}

Reações adversas

Podem induzir ganho de peso, disfunções sexuais, ansiedade, sedação, convulsões e episódios maníacos.²⁰ O bloqueio pós-sináptico muscarínico pode induzir efeitos anticolinérgicos, comuns mesmo em doses baixas. Incluem boca seca, visão turva, arritmias, vertigens, hipotensão ortostática, constipação intestinal, retenção urinária e prejuízo da memória. Quadros mais graves causam confusão mental, desorientação, alucinações visuais (ver Cap. 14, sobre *delirium*).^{9,12}

Em pacientes com distúrbio de condução cardíaca preexistente, pode haver agravamento do quadro, risco de *torsades de pointes* e morte súbita.²¹ É recomendável fazer ECG antes do início do tratamento e sempre que houver necessidade de usar doses altas.^{20,21} Os pacientes devem evitar dirigir ou operar máquinas. A retirada pode provocar síndrome de abstinência (ver Quadro 25.7).

Intoxicação

A intoxicação por ADTs é considerada uma das mais letais emergências psiquiátricas. A intervenção deve ser rápida e incisiva, pois um número significativo de pacientes morre a caminho do hospital ou nas primeiras 24 horas. Doses agudas superiores a 1 g são extremamente tóxicas e podem ser fatais. Distúrbios cardíacos são as causas mais frequentes de morte.^{7,12,21}

As manifestações clínicas de intoxicação são: agitação, confusão mental, arritmias, convulsões, midríase, hipotensão, diminuição da motilidade intestinal e retenção urinária. Alterações laboratoriais incluem hipoxemia, acidose metabólica e/ou respiratória. Níveis séricos superiores a 1 ng/mL são considerados graves.

Nas primeiras 24 horas, o paciente tem maior probabilidade de evoluir para depressão respiratória e do SNC, podendo chegar ao coma, sobretudo se houver associação de ADTs a outros depressores (álcool, benzodiazepínicos, barbitúricos). No Quadro 25.8, encontram-se procedimentos terapêuticos para tratamento da intoxicação.

QUADRO 25.8

Procedimentos básicos na intoxicação por antidepressivos tricíclicos

- Lavagem gástrica e indução de vômitos são importantes, pois não existe antídoto disponível, e a diálise é ineficaz, devido ao elevado grau de ligação proteica e tecidual dos ADTs. **Atenção:** devido à diminuição da motilidade intestinal resultante da ação anticolinérgica, a lavagem gástrica deve durar mais do que em outras intoxicações.
- Carvão ativado deve ser administrado repetidamente por meio da sonda nasogástrica, seguido do esvaziamento gástrico. A dose inicial deve ser de 1 g/kg, seguida por 20 a 25 g, a cada 4 a 6 horas.
- O tratamento dos distúrbios cardíacos se dá por meio da administração de líquidos, medicamentos vasopressores e antiarrítmicos, conforme o quadro clínico.
- É importante lembrar que os ADTs têm ação similar à da quinidina, e, assim, o uso de antiarrítmicos da classe 1 (quinidina, procainamida) é contraindicado.

- Convulsões: ocorrem sobretudo na intoxicação por maprotilina. O tratamento é com diazepam 10 mg, com administração IV lenta, repetido, se necessário. Caso se mantenham, usar fenitoína (10 mg/kg).

Inibidores da monoaminoxidase (IMAOs)

Os IMAOs são antidepressivos que inibem a ação da enzima monoaminoxidase (MAO), provocando aumento da concentração de neurotransmissores no SNC e na cadeia simpática. Essa enzima é amplamente distribuída no organismo, com maior concentração no fígado, no SNC e no trato gastrointestinal, onde é responsável pelo metabolismo da tiramina ingerida.

A tranilcipromina, um IMAO não seletivo irreversível, inibe esse metabolismo, podendo levar a crises hipertensivas. A moclobemida, por sua vez, é um inibidor reversível e seletivo da MAO-A que não provoca crises hipertensivas.

Atenção: Após uso de IMAO irreversível (tranilcipromina), aguardar pelo menos 15 dias para prescrever outro antidepressivo, para possibilitar o retorno da produção da enzima. A moclobemida pode ser substituída rapidamente por outro antidepressivo.

Reações adversas

Crise hipertensiva

Apesar de a ocorrência ser pouco frequente (em torno de 1%), a crise hipertensiva é a complicação mais grave e potencialmente fatal. Provocada pelo uso de IMAO não seletivo, essa crise ocorre quando há interação com fármacos simpatomiméticos (descongestionantes nasais, antigripais, antialérgicos) ou com alimentos ricos em tiramina (Quadro 25.9).

QUADRO 25.9

Alimentos que contêm tiramina

Evitar

- Todos os queijos, exceto ricota, requeijão ou queijo tipo minas
- Pizzas contendo queijo
- Fígado, miúdos (vísceras)
- Embutidos e enlatados: presunto, salsicha, salsichão, mortadela, salames, patês
- Peixes, conservas, enlatados de peixe ou frutos do mar
- Molho de soja, extratos de carne e sopas
- Charque e carnes defumadas
- Frutas muito maduras, como banana, abacate, etc.
- Vegetais, como vagem, favas, grão-de-bico, ervilha seca
- Vinho tinto e *Chianti*, licores, cerveja, uísque

Consumir com moderação

- Vodca, gim, vinho branco
- Chocolate
- Refrigerantes à base de cola, chás e cafés
- Nata azeda, iogurte
- Berinjela, espinafre, tomate
- Passas
- Adoçantes artificiais e aspartame

Fonte: Com base em Cordioli e colaboradores.¹¹

O tratamento desse quadro deve ser a retirada imediata do IMAO e a introdução de anti-hipertensivos.

Outros antidepressivos

Agomelatina

A agomelatina é um agonista de receptores de melatonina e antagonista neutro de receptores 5-HT_{2c} de serotonina utilizado para o tratamento da depressão. Tonturas e alterações cutâneas e gastrintestinais foram relatadas como reações adversas.²²

Bupropiona

A bupropiona bloqueia a recaptação de noradrenalina e dopamina. Tem pouca atividade serotoninérgica e não interage com receptores histamínicos e colinérgicos. É uma possibilidade para tratamento de depressões uni e bipolares e para o manejo da dependência de nicotina.^{9,22}

As reações adversas mais frequentes são agitação, ansiedade, inapetência, cefaleia, constipação e boca seca. No entanto, doses superiores a 450 mg/dia podem provocar convulsões. Não ocasiona disfunção sexual significativa, podendo ser usada como opção de potencialização ou substituição para pacientes que referem esse efeito com outras classes de antidepressivos. A intoxicação pode causar hipertensão, taquicardia, diminuição do nível de consciência, náuseas, vômitos, convulsões e sintomas psicóticos.²³

O tratamento, nesses casos, é feito por meio de lavagem gástrica e carvão ativado, a cada seis horas, se a ingestão ocorreu há menos de 12 horas; se houver convulsão, deve-se introduzir diazepam, 10 mg, IV.

Duloxetina

A duloxetina é um inibidor da recaptação de serotonina e noradrenalina com ações que aumentam a transmissão dopaminérgica. É aprovada para o tratamento de transtornos depressivos, principalmente com quadros algícos associados, dor neuropática periférica em pacientes com diabetes, fibromialgia e transtorno de ansiedade generalizada. Também pode ser usada para o tratamento de incontinência urinária de esforço.^{6,9}

Reações adversas incluem boca seca, constipação, alterações gastrintestinais, perda de apetite, alterações do sono, sudorese, disfunções sexuais, aumento pressórico e retenção urinária.²⁴ Podem ocorrer sintomas de abstinência com a suspensão abrupta (Quadro 25.7). Os casos de intoxicação são manejados com medidas de suporte, sendo os principais sintomas vômitos, convulsões, síndrome serotoninérgica, alterações pressóricas e coma. Óbito é raro.

Mirtazapina

A mirtazapina aumenta a atividade noradrenérgica e serotoninérgica central, sendo antagonista de auto e heterorreceptores alfa-2-adrenérgicos pré-sinápticos, além de antagonista 5-HT₂ e 5-HT₃ pós-sináptico. Praticamente não tem atividade anticolinérgica e dopaminérgica. É uma medicação bastante segura, mesmo em doses tóxicas. Por não afetar o sistema do citocromo P450, pode ser preferível em pacientes que precisem tomar outras medicações.⁹

Doses baixas podem ser uma estratégia para tratamento farmacológico de insônia, quando se pretende evitar o uso de benzodiazepínicos. As reações adversas são sedação excessiva, ganho de peso, boca seca, edema e constipação intestinal. Esses sintomas, no entanto, podem ser transitórios. A intoxicação pode se apresentar com desorientação, tontura, alteração da memória, taquicardia e sedação. Esse quadro deve ser tratado com lavagem gástrica com carvão ativado.

Trazodona

A trazodona inibe a recaptação de serotonina e noradrenalina. É um antagonista de receptores alfa-1-adrenérgicos e anti-histamínicos e praticamente não tem ação anticolinérgica. Em doses baixas, é indicada para o manejo farmacológico não benzodiazepínico de insônia, sobretudo em pacientes idosos.

As reações adversas são sedação, hipotensão ortostática, tontura, cefaleia, náuseas, boca seca, irritação gástrica, xerostomia e reações alérgicas. Pode provocar também arritmias em pacientes com extrassístoles ou prolapso de valva mitral preexistente.

A intoxicação apresenta os seguintes sintomas: sedação, hipotensão, perda da coordenação muscular, náuseas e vômitos. O tratamento deve incluir lavagem gástrica com administração de carvão ativado. Deve-se estimular a diurese.

Atenção: Embora raros, casos de priapismo foram relatados. Injeção intracavernosa de solução de epinefrina, 1 mcg/mL, está indicada.²⁵

Venlafaxina

A venlafaxina inibe seletivamente a recaptação de serotonina e noradrenalina, tendo fraca atividade como inibidor da recaptação de dopamina. Em doses baixas, atua basicamente como inibidor serotoninérgico, com reações adversas semelhantes às dos ISRSs. Se não houver resposta, o aumento da dose assegura os benefícios da ação dual. Esse fármaco não tem afinidades alfa₁-adrenérgica, muscarínica e histamínica.

Uma estratégia a ser considerada para depressão resistente é o uso combinado com a mirtazapina, porém, deve-se atentar à ocorrência de virada maníaca.⁹

As reações adversas podem incluir náuseas, sonolência, boca seca e tontura, mas são menos pronunciadas na forma de liberação lenta. Hipertensão pode ocorrer, sobretudo em doses superiores a 225 mg/dia. No entanto, menos de 1% dos pacientes necessita interromper o tratamento. Diminuição da libido, anorgasmia, retardo ejaculatório e impotência parecem ser dose-dependentes, não havendo desenvolvimento de tolerância.

Atenção: Com a interrupção abrupta da medicação, sintomas de abstinência com venlafaxina são particularmente proeminentes, se comparada a outros antidepressivos (Quadro 25.7).

Desvenlafaxina

A desvenlafaxina é o metabólito ativo O-desmetilvenlafaxina da venlafaxina. Geralmente bem tolerada, é aprovada para o tratamento de depressão e também indicada para outros transtornos de ansiedade e fibromialgia. As reações adversas mais comuns são náusea, tonturas, boca seca, insônia, constipação, fadiga, ansiedade e perda de apetite.²²

Vortioxetina

Embora o mecanismo de ação não seja totalmente compreendido, aparenta ser um fármaco que altera a transmissão serotoninérgica no SNC, com ações antagonistas nos receptores 5-HT₃ e agonistas nos 5-HT_{1A}. Os principais efeitos adversos são náusea e/ou vômitos, seguidos de diarreia, vertigem, boca seca, constipação e disfunção sexual. Intoxicações causam exacerbações desses sintomas, além de cólicas, prurido, rubor e sonolência.²⁶

BENZODIAZEPÍNICOS (BDZs)

Estando entre os medicamentos mais usados no mundo, os BDZs, durante muito tempo, foram caracterizados como inofensivos, mas esse fato, posteriormente, não se mostrou correto. Dependência, tolerância, abstinência e abuso vêm sendo observados quando o uso se prolonga por períodos superiores a seis semanas, sobretudo em grupos de risco, como pacientes com dependência química. O risco de dependência costuma ser maior para BDZs com ação mais ansiolítica do que hipnótica.^{6,7}

Prescrição médica indevida é outro fator de grande importância na manutenção do uso crônico de BDZs. A falta de informação e a baixa percepção das consequências deletérias do uso indevido desses medicamentos por médicos, farmacêuticos e usuários estão entre os principais fatores que favorecem esse fenômeno.²⁷

São as substâncias mais usadas em tentativas medicamentosas de suicídio, tanto isoladamente quanto associadas a outras substâncias, como álcool, em especial por pacientes com transtorno da personalidade com instabilidade emocional.²⁸ Felizmente, sua baixa toxicidade não promove índices elevados de letalidade.

Reações adversas

Sedação

A sedação é a reação adversa mais frequente; no entanto, a tolerância desenvolve-se com o passar do tempo. Não é raro ocorrer sedação diurna residual, após uso noturno de BDZs, principalmente nos de meia-vida longa, como nitrazepam, clonazepam e diazepam. O paciente deve ser orientado quanto ao risco de dirigir ou usar máquinas durante o tratamento.

Déficit de memória anterógrada, confusão mental, dificuldade de concentração e percepção sensorial, ataxia, vertigem, fraqueza muscular, com predisposição a quedas, também são queixas comuns, sobretudo em idosos e em hepatopatas. Por ter meia-vida curta e não produzir metabólitos ativos após glicoronidação hepática, o lorazepam é o BDZ de escolha quando o uso for imprescindível em idosos e hepatopatas.¹²

Efeito paradoxal

Alguns pacientes (< 1%) têm excitação ou desinibição aguda após o uso de benzodiazepínicos. O reconhecimento é importante, porque a administração inapropriada de doses maiores de BDZs piora os sintomas comportamentais (Quadro 25.10).

QUADRO 25.10

Efeito paradoxal de benzodiazepínicos

Fatores de risco

- Uso em crianças, principalmente com transtornos da aprendizagem ou história de lesão cerebral

- Demência
- Transtornos da personalidade antissocial e *borderline*
- Antecedentes de descontrolo de impulsos ou de respostas paradoxais
- Uso de BDZs de alta potência/altas doses/administrações IV

Sintomas

- Aumento de ansiedade
- Sonhos vívidos
- Hiperatividade
- Desinibição sexual
- Hostilidade e agressividade

Manejo

- Em ambiente calmo e protegido
- Antipsicóticos sedativos, se necessário
- Notificar ocorrência para profilaxia futura
- Casos extremos: considerar uso de flumazenil

Fonte: Com base em Semple e Smyth.²⁹

Síndrome de abstinência

Surge de 12 a 72 horas após a interrupção da medicação, podendo ocorrer de forma mais tardia (até o quinto dia de interrupção). O quadro clínico apresenta-se da seguinte forma: ansiedade, irritabilidade, insônia, cefaleia, agitação, falta de concentração, tensão muscular, parestesia e tremores de extremidades. O alprazolam, devido a sua meia-vida curta, é o BDZ que causa maior índice de abstinência e convulsões.

Deve-se diminuir de forma gradativa a dose do BDZ, não sendo justificada a retirada rápida, principalmente se o paciente faz uso crônico da medicação. Uma estratégia a ser usada é trocar o BDZ. Caso o paciente tome BDZs de meia-vida curta (alprazolam, lorazepam), deve-se substituí-lo por um de meia-vida longa (clonazepam, diazepam), com menor probabilidade de abstinência. A buspirona, um ansiolítico não benzodiazepínico, mostrou-se ineficaz na supressão dos sintomas de abstinência por BDZs.

Atenção: Em relação ao uso intravenoso, que é a terapêutica habitual em serviços de emergência, o BDZ deve ser aplicado de forma lenta, pois a administração rápida pode provocar depressão respiratória.

Ao prescrever diazepam IV, o médico deve acrescentar a instrução “lentamente”, para que não ocorra qualquer equívoco por parte da equipe de enfermagem quanto ao tempo de administração.

Não se deve prescrever BDZs a pacientes que chegam aos serviços de atendimento médico intoxicados por álcool. Essa substância potencializa a ação causada pelos BDZs em 20 a 30%, podendo levar a bradipneia e parada respiratória.

Intoxicação

Quadros de letalidade em uso isolado são raros. Há maior gravidade quando em associação com outros depressores do SNC, como álcool, barbitúricos ou tricíclicos. Os sintomas são: sedação acentuada, confusão mental, depressão respiratória e arritmia cardíaca. Em relação ao tratamento, ver Quadro 25.11.

QUADRO 25.11

Diretrizes para o tratamento da intoxicação por benzodiazepínicos

- Paciente com ingestão recente (menos de 6 horas) e consciente: induzir vômito.
- Paciente comatoso: lavagem gástrica com tubo endotraqueal e balonete inflado. Usar carvão ativado.
- Flumazenil – usar esse antagonista benzodiazepínico com cautela: inicia-se com 0,2 mg (2 mL) IV durante 30 segundos. Caso não ocorra melhora do nível de consciência, administrar dose adicional de 0,3 mg (3 mL) durante 30 segundos, podendo atingir uma dose acumulada de 3,0 mg. Alguns pacientes podem ter novo episódio de sedação cerca de 2 horas após o uso do medicamento, sendo necessário repetir a dose.

ANSIOLÍTICOS E HIPNÓTICOS NÃO BENZODIAZEPÍNICOS

Buspirona

A buspirona é um ansiolítico não benzodiazepínico. Não atua diretamente nos receptores GABA, agindo como agonista serotoninérgico do tipo 1A (5-HT_{1A}). Apresenta pouca ação sedativa, hipnótica, relaxante muscular ou anticonvulsivante, não havendo relatos de abstinência e intoxicação. Reações adversas: cefaleia, náusea, tonturas e, em alguns casos, insônia.⁹

Zolpidem, zopiclona

Zolpidem e zopiclona são hipnóticos não benzodiazepínicos que atuam no complexo GABA, porém de forma seletiva. São indicados como indutores do sono, não provocando outras ações comuns aos BDZs (anticonvulsivante, relaxante muscular e ansiolítica).

As reações adversas incluem sedação, sonolência residual matinal, tontura, vômitos e diarreia.

Sonolência, vômitos e disforia são os sintomas mais recorrentes na superdosagem. Depressão respiratória e coma são extremamente raros. O tratamento deve ser semelhante ao da intoxicação por BDZs.^{7,9,11}

VARENICLINA

A vareniclina é um psicofármaco aprovado para tratamento da dependência de nicotina. Atua como agonista parcial α_4 - β_2 em receptores colinérgicos nicotínicos. As reações adversas incluem náusea dose-dependente, vômitos, flatulência, constipação, insônia, cefaleia, pesadelos.^{6,12,30}

ESTABILIZADORES DO HUMOR

Lítio

O lítio é um medicamento com índice terapêutico restrito (0,5-1,5 mEq/L), exigindo atenção do profissional, principalmente no início do tratamento, quanto à possibilidade de intoxicação. Deve-se orientar o paciente a respeito das reações adversas e do quadro de intoxicação aguda.

Atenção: Deve-se monitorar a litemia, especialmente em pacientes que fazem uso de AINEs, incluindo ibuprofeno, diuréticos, sobretudo tiazídicos, e inibidores da enzima conversora de angiotensina (IECAs). Estes podem aumentar a litemia e favorecer ações tóxicas.

Reações adversas

Precoces

Ocorrem polidipsia, poliúria e sintomas gastrintestinais, como náuseas e diarreia, que tendem a desaparecer rapidamente. Tremores finos das mãos podem ocorrer, provocando, em alguns pacientes, dificuldade nos trabalhos manuais. Está indicado o uso de betabloqueador (propranolol, 20-40 mg/dia). Ganho de peso ocorre principalmente em mulheres, bem como edemas de membros inferiores. Pacientes devem ter orientação nutricional.

Em relação a alterações cardiovasculares, observa-se no ECG achatamento de onda T, porém sem relevância clínica. Doses elevadas de lítio podem causar redução da velocidade de despolarização, devendo ser usado com cautela em pacientes com arritmias.

Tardias

Podem ocorrer alterações renais, em que o lítio pode provocar redução funcional, geralmente reversível, da capacidade de concentração renal. Cerca de 10% dos pacientes que utilizam o medicamento por mais de 10 anos têm alterações morfológicas renais. No entanto, raramente causa disfunção renal clinicamente relevante.

O lítio é o principal causador de diabetes insípido nefrogênico (Quadro 25.4), que deve ser tratado com hidroclortiazida, 50 mg/dia, ou amilorida, 5 a 10 mg/dia. Caso seja necessária a introdução desses fármacos, reajustar a dose de lítio, devido à elevação da litemia.

Atenção: Pacientes com dieta hipossódica, devido à depleção de sal, podem evoluir com aumento da retenção de lítio nos rins, provocando intoxicação.

Cuidado especial deve ser prestado quando se prescreve lítio a nefropatas. Sua prescrição não é recomendada a pacientes com prejuízo grave da função renal, e, em casos mais leves, esta deve ser constantemente monitorada.

Em relação às alterações tireoidianas (Quadro 25.4), o lítio causa hipotireoidismo ou bócio nodular difuso em 5% dos pacientes, devido à inibição da captação de iodo para a tireoide. Ocorre mais em mulheres (3:1), e a dosagem do hormônio estimulante da tireoide (TSH) pode estar transitoriamente elevada, fato que não requer tratamento. Persistindo nível sérico de TSH

aumentado, com sintomas clínicos de hipotireoidismo, introduzir reposição hormonal com levotiroxina (T4). Não há necessidade de interromper o uso do lítio, mas a função tireoidiana deve ser monitorada a cada seis meses.

Intoxicação

- Leve: litemia entre 1,5 e 2,0 mEq/L. Quadro clínico: náusea, vômitos, diarreia, tremores grosseiros, disartria e mal-estar geral.
- Moderada/grave: litemia superior a 2,0 mEq/L. Quadro clínico: turvação da consciência, hipertonia muscular, fasciculação, ataxia, hiper-reflexia e convulsões, podendo chegar a coma e morte.

O Quadro 25.12 apresenta as medidas para o tratamento da intoxicação por lítio.

QUADRO 25.12

Tratamento da intoxicação por lítio

- Paciente sem disfunção renal: monitorar litemia e eletrólitos, de preferência sódio e potássio. Ocorrendo hiponatremia, infundir solução fisiológica.
- Indução de diurese com diurético osmótico (manitol) é indicada. Avaliar o equilíbrio hídrico.
- Diálise é indicada, sobretudo em pacientes com disfunção renal. Nível sérico de lítio superior a 3,5 mEq/L seria uma indicação.

Fonte: Waring.³¹

Atenção: Tentativa de suicídio com uso isolado de lítio é rara. Caso ocorra, deve-se lembrar que os picos de concentração de lítio podem surgir até 40 horas após a ingestão.

Ácido valproico

O ácido valproico é um anticonvulsivante que vem sendo amplamente usado como estabilizador do humor, indicado no tratamento de mania aguda e de episódios mistos.

Reações adversas

Ocorrem náusea, dispepsia, vômitos, diarreia, alopecia e ganho de peso. Há relatos de tremores finos de extremidades, sendo dose-dependentes. No início do tratamento, pode haver aumento das enzimas hepáticas em 40% dos pacientes, mas casos de hepatite grave são raros. Sintomas intensos de mal-estar, apatia, colúria e dor abdominal sugerem hepatotoxicidade ou pancreatite, devendo haver interrupção da medicação e investigação clínica imediata. Em mulheres jovens, há relatos de alterações menstruais, ovários policísticos e hiperandrogenismo (Quadro 25.4). Sedação em idosos é comum e pode ser associada a desidratação, desnutrição e perda de peso.^{12,32}

Atenção: O ácido valproico é contraindicado a pacientes com insuficiência hepática grave, gestantes e crianças com menos de 10 anos.

Intoxicação

É rara, podendo ser grave devido a sua rápida absorção após ingestão oral, e atinge o pico sérico em duas horas.

O quadro clínico apresenta-se da seguinte maneira: sonolência, bloqueio cardíaco e, raramente, coma. A lavagem gástrica e o uso de carvão ativado parecem ser ineficazes devido à rápida absorção do ácido valproico. Deve-se tratar, portanto, com hemodiálise ou naloxona. Esses tratamentos devem ser usados com cautela, pois podem reverter o efeito anticonvulsivante.

Carbamazepina

A carbamazepina é uma opção de estabilizador do humor para pacientes bipolares não responsivos ao lítio. É um potente indutor hepático, podendo reduzir o nível sérico de várias medicações, como anticoncepcionais, benzodiazepínicos, antipsicóticos ou outros anticonvulsivantes.^{7,12,29}

Reações adversas

Podem ocorrer sedação, náusea, vômitos e ataxia. Indica-se a introdução gradual da medicação, atenuando-se reações iniciais, pois a carbamazepina apresenta rápido desenvolvimento de tolerância. Leucopenia ocorre em até 10% dos pacientes. Hemograma completo deve ser solicitado no início do tratamento ou se o paciente tiver sinais de infecções ou sangramento. Apenas 2% dos casos evoluem para uma forma mais grave.

Cerca de 15% dos pacientes têm *rash* cutâneo, em geral benigno, raramente progredindo para dermatite esfoliativa grave ou síndrome de Stevens-Johnson.

Bloqueio atrioventricular preexistente é contraindicação relativa ao uso da carbamazepina.

Síndrome da secreção inapropriada de ADH, com hiponatremia, é uma complicação possível, e pacientes com poliúria e polidipsia devem ser investigados para essa condição (ver Quadro 25.13).

QUADRO 25.13

Fármacos associados a síndrome da secreção inapropriada de hormônio antidiurético (SIADH)*

- | | |
|------------------|---------------|
| ■ Carbamazepina | ■ Sertralina |
| ■ Amitriptilina | ■ Paroxetina |
| ■ Imipramina | ■ Venlafaxina |
| ■ Fluoxetina | ■ Citalopram |
| ■ Antipsicóticos | |

Manejo: suspender/trocar o psicofármaco; restrição hídrica; aumentar o aporte de sal na comida. Em casos graves, administrar solução salina IV e furosemida até a correção da hiponatremia.

* Riscos maiores em idosos.

Fonte: Com base em Cordioli e colaboradores.¹¹

Intoxicação

A dose letal é alta, superior a 30 vezes a dose ideal. O quadro clínico apresenta-se com diminuição do nível de consciência, midríase, nistagmo, diplopia, ataxia, vômito e retenção urinária. Falência respiratória, arritmias cardíacas, coma e morte são situações raras. Disfunções hepáticas costumam ser transitórias.³³ O tratamento é feito por meio de lavagem gástrica com carvão ativado e medidas de apoio.

Atenção: Solicitar testes de glicemia e potássio sérico, pois podem ocorrer hiperglicemia e hipopotassemia em superdosagens.^{7,9,11}

Lamotrigina

Com perfil farmacológico semelhante ao da carbamazepina, a lamotrigina vem sendo usada como opção de estabilizador do humor de manutenção, principalmente em indivíduos bipolares de difícil controle, e também no manejo da depressão bipolar.

A principal reação adversa é o *rash* cutâneo benigno, que ocorre em até 10% dos pacientes. Raramente evolui para a síndrome de Stevens-Johnson. Quando associada ao valproato, doses iniciais devem ser reduzidas à metade. Sonolência, cefaleia, diplopia, visão turva e náusea são também relatadas.^{7,29}

Topiramato

O topiramato parece ser eficaz para pacientes bipolares em comorbidade com dependência química e transtornos alimentares. As reações adversas podem ser sedação, náusea, inapetência, ataxia, parestesia, cefaleia, alterações da coordenação e da memória, diplopia, nefrolitíase e acidose metabólica hiperclorêmica.

Oxcarbazepina

Derivada da carbamazepina, a oxcarbazepina tem perfil farmacocinético distinto, com limitado efeito sobre as enzimas microssomais e menor interação medicamentosa. Aprovada pela FDA para o tratamento de epilepsia, é usada também para o tratamento de pacientes bipolares (mania aguda e terapia de manutenção).

Entre as reações adversas, estão sedação leve, cefaleia, ataxia, nistagmo, fadiga, confusão, ansiedade, náusea, dispepsia, vômitos, dores abdominais e *rash*. As manifestações clínicas da intoxicação são semelhantes às da carbamazepina.

PSICOESTIMULANTES

Metilfenidato

Disponível em formas de liberação lenta e imediata, as ações do metilfenidato se relacionam ao aumento das atividades noradrenérgica e, especialmente, dopaminérgica centrais, por bloqueio de recaptação desses neurotransmissores.¹²

Aprovado pela FDA para tratamento farmacológico da narcolepsia e do transtorno de déficit de atenção/hiperatividade (TDAH) em adultos e crianças, suas principais reações adversas se relacionam às ações periféricas da noradrenalina (tremores, taquicardia, cefaleia, hipertensão, arritmias) e centrais, tanto da noradrenalina quanto da dopamina (insônia, exacerbação de tiques, irritabilidade, agitação psicomotora, psicoses e potencial de abuso). Pode provocar anorexia, perda de peso, visão borrada e dores abdominais. Efeitos sobre a redução do crescimento de crianças são controversos, mas devem ser monitorados. Deve-se interromper a medicação se as reações adversas se mantiverem.⁹

A intoxicação caracteriza-se por um quadro de hiperatividade simpática, com hipertensão, taquicardia, convulsões e hipertermia. Pode ser acompanhada de quadros psicóticos, *delirium*, ideias delirantes paranoides, irritabilidade e comportamento violento. O tratamento desses casos deve ser feito por meio da prescrição de betabloqueadores, diazepam, na ocorrência de convulsões, e antipsicóticos sedativos, nos casos de *delirium*.^{6,29}

Modafinil

O modafinil tem uso aprovado para tratamento de narcolepsia e de sonolência associada a apneia/hipopneia obstrutivas. As reações adversas incluem potencial de abuso, cefaleia, ansiedade, insônia, alterações gastrintestinais, infecção de vias aéreas superiores, hipertensão, palpitações e, mais raramente, ativação de quadros maniformes, ideação suicida, alucinações e farmacodermias. Intoxicações não costumam ser letais, mas cursam com importante agitação, insônia e aumento/aceleração de parâmetros hemodinâmicos.⁹

O Quadro 25.14 resume estratégias de manejo de algumas reações adversas de psicofármacos. O Quadro 25.15 contém “toxíndromes” relacionadas a substâncias, medicamentos ou não, que produzem efeitos adversos/intoxicações.

QUADRO 25.14

Estratégias de manejo de algumas reações adversas comuns de psicofármacos

Arritmias

- Monitoramento eletrocardiográfico em pacientes de alto risco e em uso de psicofármacos arritmogênicos.
- Evitar o uso de ADTs em pacientes com bloqueio de condução, isquemia cardíaca e em idosos.

Boca seca (risco de cáries e estomatites)

- Cuidados com a higiene bucal.
- Gomas de mascar e balas sem açúcar.
- Casos mais graves: bochechos com solução de pilocarpina 4% (há colírios que podem ser dissolvidos em água) ou betanecol, 5-10 mg, sublingual.

- Cefaleia, náuseas, tonturas, diarreia**
- Costumam melhorar com o tempo de uso. Se muito intensas, trocar medicamento.
- Constipação**
- Dieta rica em fibras, laxantes naturais.
- Convulsões**
- Suspende os medicamentos e solicitar consultoria neurológica. Se necessário, diazepam, IV.
 - Não associar clozapina com fenitoína ou carbamazepina.
- Disfunções sexuais**
- Considerar troca de medicação.
 - Considerar possibilidade de associação a bupropiona, 150-300 mg/dia; ciproptadina, 4 mg, para mulheres anorgásmicas; betanecol, 10-50 mg, 1-2 horas antes do ato sexual, para homens com retardo ejaculatório ou anorgasmia; sildenafila ou tadalafila em homens com disfunção erétil (atenção: não coadministrar com nitratos, pelos riscos hipotensivos).
- Hipertensão**
- Casos leves: nifedipina, 10 mg, sublingual.
 - Casos graves: bloqueadores alfa-adrenérgicos (devem ser manejados em ambiente hospitalar).
- Hipotensão ortostática**
- Hidratação adequada, uso de meias elásticas.
 - Não havendo contra-indicações: fludrocortisona, 0,02-0,05 mg, a cada 12 horas.
- Rash cutâneo**
- Costuma remitir espontaneamente. Casos graves: suspender o fármaco e substituir por um de outra classe. Solicitar avaliação dermatológica.
- Retenção urinária**
- Betanecol, 10-50 mg, 2-3 vezes/dia.
- Sialorreia**
- Biperideno, 2-6 mg/dia; clonidina, 0,1 mg/noite; amitriptilina; difenidramina ou atropina em solução 1% ou 1-2 gotas sublinguais à noite.
- Taquicardia e tremores pronunciados**
- Propranolol, 30-80 mg/dia, em 3 administrações (não usar em casos de asma, doença pulmonar obstrutiva, insuficiência vascular periférica, bradicardia, insuficiência cardíaca).

QUADRO 25.15

Achados clínicos proeminentes em “toxíndromes” relacionadas a reações adversas/intoxicações por substâncias importantes na prática psiquiátrica

Classe da droga	Exemplos	Sinais clínicos	Antídoto
Anticolinérgicos	Atropina, anti-histmínicos, escopolamina, antiespasmódicos, tricíclicos, fenotiazinas, agentes antiparkinsonianos	Agitação, alucinações, taquicardia, midríase, secura de membranas, hipertermia, diminuição de ruídos hidroaéreos, retenção urinária, pele seca, rubor	Fisostigmina
Colinérgicos	Organofosforados, inseticidas carbamatos, inibidores da colinesterase	Hipersalivação, lacrimejamento, incontinência, cólica gastrointestinal, êmese, bradicardia, sudorese, miose, edema pulmonar, fraqueza, paralisia, fasciculações	Atropina, pralidoxima
Opioides	Oxicodona, hidrocodona, hidromorfona, fentanila, morfina, propoxifeno, codeína, metadona, heroína	Depressão do SNC e respiratória, miose, bradicardia, hipotensão, hipotermia, edema pulmonar, hiporreflexia	Naloxona, nalmefeno
Sedativos-hipnóticos	Benzodiazepínicos, zolpidem, zaleplom, zopiclona, barbitúricos, etanol, hidrato de cloral, meprobamato	Depressão do SNC, hiporreflexia, bradipneia, hipotensão, hipotermia, bradicardia	Flumazenil (para alguns)

Simpatomiméticos	Psicoestimulantes, anfetaminas, pseudoefedrina, fenilefrina, efedrina, cocaína	Hipertensão, taquicardia, arritmias, agitação, paranoia, alucinações, midríase, náusea, vômitos, dor abdominal, piloereção	Benzodiazepínicos
Neurolépticos	Antipsicóticos típicos e atípicos, antieméticos fenotiazínicos	Hipotensão, crises oculógiras, trismo, distonia, ataxia, parkinsonismo, manifestações anticolinérgicas (alguns)	Fisostigmina (para alguns)
Serotonérgicos	IRSNs, IRSRs, ADTs, IMAOs, buspirona, tramadol, antieméticos, triptanos, sibutramina	Acatisia, tremores, agitação, hipertermia, hipertensão, diaforese, hiper-reflexia, clônus, hipertonía muscular de extremidades inferiores, diarreia	Benzodiazepínicos, cipro-heptadina
<i>Fonte: Com base em Rasimas.³⁸</i>			

Lisdexanfetamina

É um pró-fármaco terapeuticamente inativo que, uma vez convertido no fígado em dextroanfetamina, aumenta as ações da noradrenalina e da dopamina, facilitando sua liberação e bloqueando sua recaptação. Utilizada para o tratamento do TDAH e da narcolepsia, foi desenvolvida com o objetivo de ser um estimulante de ação prolongada e menor potencial de abuso. Seus efeitos colaterais mais comuns se assemelham aos do metilfenidato, bem como os sintomas diante de quadros de intoxicação. Deve ser evitado em pacientes com anormalidades cardíacas preexistentes.^{9,11}

INIBIDORES DA ACETILCOLINESTERASE E MEMANTINA

Os principais inibidores da acetilcolinesterase são rivastigmina, galantamina e donepezila, que provocam aumento na transmissão colinérgica central. Há evidências de pequenas melhoras nos sintomas cognitivos em certos quadros demenciais.³⁴ Os efeitos adversos incluem sintomas gastrintestinais, tonturas, cefaleia, cólicas abdominais, insônia e perda de apetite. Quadros de intoxicação intensificam tais sintomas e podem provocar fraqueza muscular, fasciculações e outros sinais de crise colinérgica, como salivação, lacrimejamento, sudorese, bradicardia, hipotensão, incontinência urinária e fecal e convulsões. O tratamento envolve medidas de suporte e, em casos graves, uso de atropina.^{9,35}

A memantina, por sua vez, é um antagonista não competitivo de receptores glutamatérgicos N-metil-D-aspartato (NMDA), bloqueando-os apenas em condições de excessiva estimulação. É utilizada no tratamento de formas moderadas a graves de demência na doença de Alzheimer, e seus efeitos adversos mais comuns são cefaleia, cansaço, tontura, fraqueza, confusão mental, constipação, tosse, hipertensão e dores lombares. Na intoxicação, podem ocorrer agitação ou sonolência, sintomas psicóticos, tonturas e desmaios. O tratamento é sintomático e de suporte.^{11,34}

ORGANOFOSFORADOS E CARBAMATO (“CHUMBINHO”)

Os organofosforados e o carbamato (“chumbinho”) *não* são medicamentos. Pelo contrário, tratam-se de substâncias tóxicas, com alto potencial de letalidade. Devido a sua disponibilidade comercial, muitas vezes são usados por indivíduos que cometem tentativas de suicídio por envenenamento. Tal fato justifica a importância de todos os médicos conhecerem as principais medidas para o manejo de quadros de intoxicação por esses produtos.

Organofosforados

Organofosforados são pesticidas amplamente empregados na agricultura, na horticultura e na medicina veterinária. No início da década de 1980, a Organização Mundial da Saúde estimava em 2 milhões de casos anuais a intoxicação aguda por organofosforados, com pelo menos 5 milhões de mortes nas três últimas décadas.³⁶ Um número significativo desses casos se deve aos poucos cuidados na manipulação da substância, levando à contaminação. Seu uso como instrumento de tentativa de suicídio, principalmente na zona rural, também é marcante.

Os compostos organofosforados são inseticidas que inibem a enzima acetilcolinesterase, cuja principal função é catalisar a hidrólise da acetilcolina em ácido acético e colina.³⁷ A absorção do veneno, via gastrointestinal, pulmonar ou cutânea, provoca a inativação da enzima, desencadeando um acúmulo desta no SNC e a consequente hiperestimulação dos receptores colinérgicos muscarínicos e nicotínicos. Na intoxicação, deve-se considerar a via de absorção, o grau e o tempo de exposição e a toxicidade da substância.

Manejo da intoxicação aguda

As manifestações surgem de 5 minutos a 24 horas após a exposição. O quadro clínico é dividido em crise colinérgica, síndrome intermediária, polineuropatia tardia e transtornos do comportamento.

A crise colinérgica ocorre devido ao acúmulo de acetilcolina em receptores muscarínicos (bradicardia, hipotensão, broncoespasmo, aumento da secreção brônquica, edema agudo de pulmão, miose e incontinência urinária), nicotínicos (caimbras, contrações, fasciculações e fraqueza muscular, inclusive da musculatura intercostal) e do SNC (confusão mental, agitação psicomotora, convulsão, coma e morte).

A principal causa de morte na intoxicação aguda é a insuficiência respiratória.

A síndrome intermediária ocorre entre 24 e 96 horas após a intoxicação e se caracteriza, basicamente, por fraqueza muscular, podendo evoluir para morte por paralisia dos músculos respiratórios.

A polineuropatia tardia surge até quatro semanas após a crise colinérgica, predominando fraqueza muscular, dores e parestesia de membros.

Os transtornos do comportamento podem durar vários meses, com alteração das memórias de fixação/evocação recentes, irritabilidade, ansiedade e depressão.

Carbamato – “chumbinho”

O carbamato é um inseticida anticolinesterásico, também usado como raticida. Observa-se crescente número de tentativas de suicídio, bem como de intoxicações pediátricas acidentais, com esse produto. Estruturalmente, tem ação semelhante à dos organofosforados, inibindo a acetilcolinesterase e impedindo a inativação da acetilcolina. O fator diferencial dessas substâncias é que o carbamato promove carbamidação na enzima, ao passo que o organofosforado promove uma fosforilação.

A via de absorção e as manifestações clínicas também são semelhantes às dos organofosforados. Deve-se salientar que poucos são os hospitais no Brasil que têm laboratórios capazes de realizar análise toxicológica de forma rápida e eficaz. Nas manifestações agudas, quando não se sabe se houve contato com alguma substância tóxica, a miose associada à bradicardia e à sialorreia leva à suspeita de intoxicação por inseticidas.

Manejo da intoxicação aguda

O manejo da intoxicação aguda é semelhante ao descrito para os organofosforados (Quadro 25.16), à exceção do uso da pralidoxima, pois o mecanismo de ação do carbamato consiste na inibição transitória da colinesterase. Com o manejo, a atividade da enzima é rapidamente restaurada. Além disso, a pralidoxima pode diminuir a efetividade da atropina em casos de intoxicação por carbamatos.

QUADRO 25.16

Tratamento da intoxicação aguda por organofosforados

- Interrupção imediata da exposição.
- Retirar as roupas e lavar intensamente pele e mucosas.
- Intoxicação por ingestão: lavagem gástrica.
- Administração de atropina é necessária, devido à ação antagonista eficaz nos receptores muscarínicos, diminuindo as secreções traqueobrônquica, salivar e a broncoconstrição. A dose inicial é de 2-4 mg, IV. Não sendo possível essa via, administrar 2 mg, IM, a cada 5-10 minutos, até que desapareçam os sintomas muscarínicos. Caso reapareçam, aplicar novamente. Ficar atento, no entanto, a uma possível intoxicação atropínica.
- **Atenção:** A atropina não atua contra a ativação neuromuscular periférica e a paralisia subsequente, sendo necessária, em intoxicações moderadas ou graves, a introdução de pralidoxima.
- Pralidoxima: 1-2 g/dia, em doses de 200-400 mg, IV, lentamente. Caso não haja melhora, repetir a dose por vários dias.
- Outras condutas: manutenção das vias respiratórias pérvias, com aspiração endobrônquica; intubação endotraqueal, quando necessário. Ocorrendo convulsão, administrar diazepam, 10 mg, IV, lentamente.
- **Atenção:** em situações graves, devido à lenta absorção do organofosforado, recomenda-se a manutenção de atropina e pralidoxima por mais 48 horas ou pelo tempo em que houver sinais de intoxicação.

Fonte: Eddleston e Chowdhury.³⁶

Atenção: Em casos de intoxicação por carbamato em que o paciente não responde à terapia com atropina, deve-se avaliar a possibilidade da presença de organofosforado associado. Nessas situações, recomenda-se o uso da pralidoxima.

REFERÊNCIAS

1. Gründer G, Heinze M, Cordes J, Mühlbauer B, Juckel G, Schulz C, et al. Effects of first-generation antipsychotics versus second-generation antipsychotics on quality of life in schizophrenia: a double-blind, randomised study. *Lancet Psychiatry*. 2016;3(8):717-29.
2. Affaticati A, Gerra ML, Amerio A, Inglese M, Antonioni MC, Marchesi C. The controversial case of biperiden: from prescription drug to drug of abuse. *J Clin Psychopharmacol*. 2015;35(6):749-50.
3. Gomes RQD, Dos Santos-Júnior A, Dias GA de AS, Cais CF da S. Diagnosis and implications in the therapeutic management of patient with afebrile neuroleptic malignant syndrome. *Oxf Med Case Reports*. 2016;2016(9):omw067.
4. Kinon BJ, Kollack-Walker S, Jeste D, Gupta S, Chen L, Case M, et al. Incidence of tardive dyskinesia in older adult patients treated with olanzapine or conventional antipsychotics. *J Geriatr Psychiatry Neurol*. 2015;28(1):67-79.
5. Quevedo J, Carvalho AF. Emergências psiquiátricas. 3. ed. Porto Alegre: Artmed; 2014.
6. Stahl S. Stahl's essential psychopharmacology: neuroscientific basis and practical applications. 4th ed. New York: Cambridge University; 2014.
7. Bazire S. Psychotropic drug directory. Aberdeen: HealthComm; 2014.
8. U.S. Food and Drug Administration. Information for healthcare professionals: haloperidol (marketed as haldol, haldol decanoate and haldol lactate) [Internet]. Silver Spring: FDA; 2017 [capturado em 19 jan. 2017]. Disponível em: <http://www.fda.gov/Drugs/DrugSafety/PostmarketDrugSafetyInformationforPatientsandProviders/DrugSafetyInformationforHealthcareProfessionals/ucm085203.htm>.
9. Stahl S. The prescriber's guide: Stahl's essential psychopharmacology. Cambridge: Cambridge University; 2014.
10. Costa AMN, Gonçalves I. Alterações cardiovasculares induzidas pelo uso de medicações psicotrópicas. *Psiquiatria Prática Méd*. 2001;34(2).
11. Cordioli AV, Gallois CB, Isolan L, organizadores. Psicofármacos: consulta rápida. 5. ed. Porto Alegre: Artmed; 2015.
12. Schatzberg AF, DeBattista C. Manual of clinical psychopharmacology. 8th ed. Washington: APA; 2015.
13. Stern TA, Fricchione GL, Rosenbaum JF. Massachusetts general hospital handbook of general hospital psychiatry. St. Louis: Elsevier; 2010.
14. Ferrando SJ, Levenson JL, Owen JA, editors. Clinical manual of psychopharmacology in the medically ill. Washington: APA; 2010.
15. Looper KJ. Potential medical and surgical complications of serotonergic antidepressant medications. *Psychosomatics*. 2007;48(1):1-9.
- 16 Fava GA, Gatti A, Belaise C, Guidi J, Offidani E. Withdrawal Symptoms after Selective Serotonin Reuptake Inhibitor Discontinuation: A Systematic Review. *Psychother Psychother Psychosom*. 2015;84(2):72-81.

17. de Abajo FJ, García-Rodríguez LA. Risk of upper gastrointestinal tract bleeding associated with selective serotonin reuptake inhibitors and venlafaxine therapy: interaction with nonsteroidal anti-inflammatory drugs and effect of acid-suppressing agents. *Arch Gen Psychiatry*. 2008;65(7):795-803.
18. Schalekamp T, Klungel OH, Souverein PC, de Boer A. Increased bleeding risk with concurrent use of selective serotonin reuptake inhibitors and coumarins. *Arch Intern Med*. 2008;168(2):180-5.
19. Andrade C, Sandarsh S, Chethan KB, Nagesh KS. Serotonin reuptake inhibitor antidepressants and abnormal bleeding: a review for clinicians and a reconsideration of mechanisms. *J Clin Psychiatry*. 2010;71(12):1565-75.
20. Coupland C, Morriss R, Arthur A, Moore M, Hill T, Hippisley-Cox J. Safety of antidepressants in adults aged under 65: protocol for a cohort study using a large primary care database. *BMC Psychiatry*. 2013;13:135.
21. Coupland C, Dhiman P, Morriss R, Arthur A, Barton G, Hippisley-Cox J. Antidepressant use and risk of adverse outcomes in older people: population based cohort study. *BMJ*. 2011;343:d4551.
22. Carvalho AF, Sharma MS, Brunoni AR, Vieta E, Fava GA. The safety, tolerability and risks associated with the use of newer generation antidepressant drugs: a critical review of the literature. *Psychother Psychosom*. 2016;85(5):270-88.
23. Shepherd G, Velez LI, Keyes DC. Intentional bupropion overdoses. *J Emerg Med*. 2004;27(2): 147-51.
24. Taylor D, Paton C, Kapur S; South London and Maudsley NHS Trust. The maudsley prescribing guidelines in psychiatry. London: Wiley; 2015.
25. Sharma TR. Priapism lasting 19 hours with combined use of trazodone and mirtazapine in a patient with history of successfully tolerating each agent as monotherapy. *Prim Care Companion CNS Disord*. 2012;14(5): PCC.12l01349.
26. Medscape. Vortioxetine (Rx) [Internet]. Medscape; c2017 [capturado em 19 jan. 2017]. Disponível em: <http://reference.medscape.com/drug/trintellix-brintellix-vortioxetine-999882#4>.
27. Kapczinski F, Amaral OB, Madruga M, Quevedo J, Busnello JV, de Lima MS. Use and misuse of benzodiazepines in Brazil: a review. *Subst Use Misuse*. 2001;36(8):1053-69.
28. Kim J, Kim M, Kim YR, Choi KH, Lee KU. High prevalence of psychotropics overdose among suicide attempters in Korea. *Clin Psychopharmacol Neurosci*. 2015;13(3):302-7.
29. Sempe D, Smyth R, editors. *Oxford handbook of psychiatry*. Oxford: Oxford University; 2013.
30. Jorenby DE, Hays JT, Rigotti NA, Azoulay S, Watsky EJ, Williams KE, et al. Efficacy of varenicline, an $\alpha 4\beta 2$ nicotinic acetylcholine receptor partial agonist, vs placebo or sustained-release bupropion for smoking cessation: a randomized controlled trial. *JAMA*. 2006;296(1):56-63.
31. Waring WS. Management of lithium toxicity. *Toxicol Rev*. 2006;25(4):221-30.

32. Brodie MJ, Besag F, Ettinger AB, Mula M, Gobbi G, Comai S, et al. Epilepsy, Antiepileptic drugs, and aggression: an evidence-based review. *Pharmacol Rev.* 2016;68(3):563-602.
- 33 Alrashood ST. Carbamazepine. *Profiles Drug Subst Excip Relat Methodol.* 2016;41:133-321.
34. Hugo J, Ganguli M. Dementia and cognitive impairment: epidemiology, diagnosis, and treatment. *Clin Geriatr Med.* 2014;30(3):421-42.
35. Magierski R, Sobow,T. Benefits and risks of add-on therapies for Alzheimer's disease. *Neurodegener Dis Manag.* 2015;5(5):445-62.
36. Eddleston M, Chowdhury FR. Pharmacological treatment of organophosphorus insecticide poisoning: the old and the (possible) new. *Br J Clin Pharmacol.* 2016;81(3):462-70.
37. Polimeno N. Níveis das colinesterases plasmática e eritrocitária em doadores voluntários da região de Bragança Paulista SP como indicadores de intoxicação crônica por organofosforados [dissertação]. São Paulo: Universidade Federal de São Paulo; 1995.
38. Rasimas JJ. Medical toxicology. In: Levenson JL, editor. *The american psychiatric publishing textbook of psychosomatic medicine: psychiatric care of the medically ill.* 2nd ed. Washington: APA; 2011. p. 929-53.

SITE RECOMENDADO

American Psychiatric Association. Diagnostic and statistical manual of mental disorders [Internet]. Arlington: APA; 2017 [capturado em 19 jan. 2017]. Disponível em: <http://psychiatryonline.org/>.

APLICATIVO RECOMENDADO

Medscape for IOS and for Android. 1994-2015 WebMD, LLC. Reuters Health Information. 2015.



Crise: abordagem psicodinâmica

Neury José Botega
Mario Eduardo Costa Pereira
Joel Giglio

Certos acontecimentos inesperados interrompem o curso normal da vida. Retiram-nos de um mundo conhecido e relativamente previsível para nos manter suspensos na linha do tempo. Escravos de um corpo que agora parece correr à parte e tendo o tempo controlado pela rotina de cuidados, a doença aguda e a internação hospitalar abalam um modo de viver que tanto demandara de esforço estratégico e de investimento afetivo. Este capítulo aborda a importância de se dar continência a uma pessoa que vivencia a catástrofe, ou a crise existencial. Diante de uma pessoa para quem o mundo acabou de desabar, devemos ter uma atitude de escuta privilegiada, em interação, feita por um profissional que não é necessariamente um psicoterapeuta. Isso é fundamental para o sujeito se sentir escutado e para colocar em marcha um processo efetivo de elaboração, que se prolonga mesmo depois que o médico vai embora.

A CATÁSTROFE

Primeiro vem a catástrofe: sou frágil, posso morrer! Sobre fragilidade e mortalidade, sempre soubemos, mas era apenas racionalmente, como uma espécie de realidade que só acontece para os outros. Agora, trata-se de uma constatação forçada. A internação faz desabar inapelavelmente nosso narcisismo, nossa negação, nossa onipotência – as soluções precárias –, as “gambiaras” com as quais conseguíamos ir tocando a vida.

O que pode sobrevir a esse desabamento? O desespero, o reforço da negação, o buraco melancólico-depressivo, as regressões sem-fim, o suicídio... A catástrofe pode levar ao colapso existencial, com vivências de angústia de aniquilamento, desamparo, incapacidade e esgotamento, com falta de perspectiva de solução. Se ultrapassar a capacidade pessoal de reação e de adaptação, a catástrofe pode aumentar a vulnerabilidade para o suicídio, que passa a ser visto como única saída para uma situação insuportável.

Após a catástrofe pode vir uma crise existencial, o que não é algo negativo, nem se afasta do que podemos considerar normal. Se sobrevier a essa fase crítica, o desespero se transformará aos poucos em palavras, ainda de forma desordenada, mas já com alguma “luz no fim do túnel”. A vivência de catástrofe vai se enfraquecendo. Trata-se de começar a pensar. Em meio a temores e inseguranças, haverá, também, intensa movimentação psíquica direcionada para a sobrevivência e, junto com esta, a necessidade de fazer um balanço de vida. Será preciso definir, ou modificar, as prioridades, não só no mundo externo, mas, principalmente, no mundo interno.

A consciência da vulnerabilidade e da finitude faz vir à tona essa urgência. Na solidão dos pensamentos ou na proximidade repentina de parentes e amigos, reavivam-se os conflitos silenciados. As pendências consigo mesmo e com os outros vêm à tona e caracterizam esse momento de crise. Em uma fase seguinte, de elaboração e tomada de posições, é preciso encontrar algumas certezas, apoio e esperança.

Há certa “temporalidade típica” no que descrevemos até aqui: primeiro, catástrofe; segundo, crise; e terceiro, elaborações e tomada de posições. O terceiro movimento psíquico é fundamental para sobreviver à catástrofe, ao navegar pela crise, conseguir dar os primeiros passos em direção a alguma elaboração e reorganização possíveis.

No paciente que ocupa um leito hospitalar, há desespero, temores, dúvidas, esperanças e urgências psíquicas. Há, enfim, uma catástrofe, ou crise pessoal, em curso. Isso pode ser um fio condutor para definir o que deve orientar uma abordagem psicodinâmica, ou seja, ajudar o sujeito a transformar a catástrofe introduzida pela doença e pela internação em uma crise – encruzilhada, decisão – que o ajude a resgatar sua vida, agora vista com novos olhos, após um desabamento existencial.

No entanto, se a experiência clínica e a leitura feita até aqui fazem essa dimensão do adoecimento parecer tão humana e tão óbvia, por que será que, na prática, tantos profissionais agem sem levar em conta as necessidades emocionais de seus pacientes?

Muitos fatores se combinam para tornar o médico pouco permeável a **vivências emocionais intensas**. Sob enfoques diferentes e complementares, alguns capítulos deste livro aprofundam a

discussão das questões psicológicas que cercam a interação entre o médico e seu paciente. Funcionam como uma base para o presente capítulo, que é de caráter mais pragmático.^[NT]

Um campo intersubjetivo

A percepção de uma catástrofe, ou de uma crise humana, só pode ocorrer se, antes de qualquer coisa, considerarmos a pessoa do paciente. Na prática clínica, tal percepção só é possível se estivermos permeáveis à ideia de que acolher angústias faz parte da tarefa assistencial. Isso é perturbador para alguns profissionais da saúde, para os quais o que mais pesa e cansa na assistência é, exatamente, interagir (e se emocionar).

Na atualidade, mesmo na formação médica, essa dimensão humana, clínica, no sentido mais profundo do termo, é quase totalmente desvalorizada e colocada em segundo plano. Os jovens estudantes de medicina têm poucos exemplos em seus professores, os quais aprendem a admirar apenas pelas competências científicas e técnicas, muito pouco pela qualidade do contato humano que eles empreendem com seus pacientes.

Vários mecanismos de defesa psicológica são ativados e se combinam com a finalidade de evitar a interação com dramas humanos e, conseqüentemente, nos proteger.^[NT] Ao auxílio dos chamados mecanismos de defesa da psique, vêm os preconceitos, as construções teóricas pessoais, a impessoalidade do “tocar a demanda”, o cumprimento de protocolos, a repulsa automática. Esses elementos contribuem para a noção que construímos a respeito do que deve permanecer fora de nossa responsabilidade profissional.

Tal construção funciona como uma couraça de proteção que enrijece a maneira como nos conduzimos diante dos pacientes.^[NT] O problema é que, na ausência de uma postura acolhedora, a percepção e a formulação diagnóstica tornam-se embaçadas. Diferentemente do que pode pregar um ou outro defensor de posturas rígidas e estereotipadas, a frieza afetiva bloqueia o raciocínio clínico. Ela impede a valorização de aspectos essenciais para o diagnóstico, a adesão e a recuperação do paciente. Um exemplo disso é apresentado no Quadro 26.1.

QUADRO 26.1

Um exemplo de prejuízo da percepção e do raciocínio clínico

Atitudes orientam as ações

Verificamos que muitos profissionais da saúde têm concepções errôneas e sentimentos negativos em relação ao comportamento suicida. Essa atitude acaba por condicionar a ação ou inação diante dos pacientes que têm risco de pôr fim à própria vida. Perdura o receio de perguntar sobre ideação suicida e, assim, despertar o ato até então latente. Outro receio é ouvir um “sim” do paciente e, a partir de então, angustiar-se com duas preocupações, como ser o responsável pela vida de alguém (o que não é bem assim, essencialmente) e ter de fazer alguma coisa (sim, algo deveria ser feito; a princípio, ouvir o que o paciente tem a dizer).

Diante desses dois dilemas – a pergunta potencialmente letal e a impotência angustiante diante de uma resposta afirmativa –, o profissional nem cogita a possibilidade de o paciente estar se debatendo com ideias de pôr fim à própria vida. Dessa maneira, a avaliação do risco de suicídio não é feita. Caso o paciente venha a cometer suicídio, isso deixará o profissional em uma situação muito embaraçosa, incluindo o risco de ser processado pela família do falecido.

O que destacamos como aspecto fundamental na situação clínica exemplificada é que um dos melhores sinalizadores da presença do risco de suicídio é a consciência, no avaliador, da própria ansiedade diante do paciente potencialmente suicida. A incapacidade de experimentar sentimentos, decorrente de um contato empático pobre, de falsas crenças e de defesas da psique, impede a boa avaliação clínica e, posteriormente, o trabalho terapêutico.

Fonte: Botega.¹

Contudo, é interessante como, antes mesmo de quaisquer perguntas e respostas sobre assuntos mais íntimos e delicados, algo se opera na relação estabelecida entre profissional e paciente, às vezes logo nos primeiros minutos: quão à vontade e confiante um se sente diante do outro. De alguma forma, o paciente percebe se há espaço para se abrir, ou seja, se o profissional lhe garante esse espaço. De fato, o paciente nunca vai além do espaço que percebe que o médico lhe permite. Alguns pacientes tentam “forçar a porta”, mas logo diagnosticam – com razão – a incapacidade do médico de acolher aquilo que ele – o paciente – deseja expressar.

Trata-se, na realidade, não de um espaço que um proporciona ao outro, mas de um campo relacional intersubjetivo que envolve e condiciona os encontros humanos, que envolve trocas emocionais.^[NT] É a qualidade desse espaço de interação que permite uma boa avaliação clínica e, posteriormente, o estabelecimento de uma aliança terapêutica. Esta, em si, é um importante fator para enfrentar a crise.

A CRISE

Na catástrofe emocional, o que está em primeiro plano é o desabamento psíquico e suas consequências. A crise, tal como a concebemos aqui, é uma das consequências subjetivas possíveis da catástrofe. É o momento do balanço de vida, de se colocar em questão, de decidir novos caminhos. É claro que a “escolha” feita no momento de crise pode não ser tão favorável. Da crise, pode resultar o recrudescimento das defesas, da negação, da repetição e da ideação suicida.

A palavra “crise” deriva do Grego *krisis*, que significa separação. O verbo *krinein* significa separar, escolher, julgar. *Krisis* é a ação ou a faculdade de distinguir e tomar uma decisão; por extensão, é o momento decisivo, difícil de separar, decidir, julgar.

Há as crises vitais do desenvolvimento e as crises circunstanciais. As primeiras ocorrem à medida que envelhecemos, quando surgem dificuldades na passagem de uma fase da vida para outra, e são inerentes ao desenvolvimento humano. As crises circunstanciais originam-se de acontecimentos raros e extraordinários, situações que o indivíduo não tem como controlar.

A crise pode ser tão dolorosa quanto potencialmente útil, variando com a gravidade daquilo que ela afeta ou põe em causa. O significado de um acontecimento, de uma situação inesperada, precisa ser encontrado e integrado na história do sujeito, incorporando-se a uma nova perspectiva de vida. De fato, no curso habitual ou “normal”, observamos que, a partir de algum momento de crise, há gestação de ideias e de planos. Isso representa um importante passo para a recuperação do equilíbrio pessoal.

Às vezes, a crise se prolonga, as ideias não se organizam, e o sujeito não consegue criar uma narrativa significativa para compreender o que lhe aconteceu. Em decorrência disso, podem sobrevir o esgotamento e a depressão. Pode também ocorrer de uma reação de luto se prolongar tanto que o médico fique em dúvida sobre a necessidade de iniciar ou não o tratamento com um antidepressivo e encaminhar o paciente para a psicoterapia. Na prática clínica, nem sempre é fácil diferenciar quando uma reação de ajustamento depressivo dá lugar a um quadro de depressão.^[NT]

Deve-se lembrar que há um caráter contagioso nas crises. Pessoas próximas ao paciente – familiares, amigos e membros da equipe assistencial – podem ser afetadas. Não é raro o interconsultor entrar em uma enfermaria e, de imediato, ter de acolher a demanda de várias pessoas que, ansiosas, a ele se dirigem com queixas e questionamentos.^[NT] O treinamento e a sensibilidade do profissional permitirão uma postura calma de acolhimento, observação e reflexão. É preciso suportar essa pressão e manter a capacidade de analisar e agir em um ambiente de forte impacto emocional.

MANEJO

A distinção entre catástrofe e crise implica manejos diferentes. Uma coisa é a atitude clínica necessária diante de um sujeito para quem o mundo desabou, e outra, para quem a catástrofe inicial evoluiu e fez com que ele tivesse de se colocar radicalmente em questão.

Diante de um paciente que vivencia a catástrofe, o mais importante no manejo psicodinâmico é que o médico evite, em si, o desespero e a passagem ao ato. Não só o médico, mas, sobretudo, o paciente, nessa circunstância, pode passar ao ato. Tentamos, paciente e progressivamente, dar algum espaço para a palavra.

A crise constitui um momento posterior. Uma vez constatado o desabamento tão insuportável, o sujeito se interroga diante de nós: “E agora? O que mesmo que aconteceu? Que coisas profundas em mim esse *tsunami* existencial fez vir à tona? O que faço com elas?”. Diante de questões tão radicais, que levam o sujeito a interrogar suas raízes e seus fundamentos, alguns pacientes voltam a se defender, outros regridem e outros se desesperam.

Felizmente, não é raro que pacientes obtenham um ganho de verdade a respeito de si próprios e um estímulo único para voltarem a se situar diante da vida presente e futura. É claro que não está ao alcance do clínico conduzir o paciente a optar pelo novo caminho, supostamente mais saudável. No entanto, ele pode ajudá-lo a passar do desespero à encruzilhada e da encruzilhada para uma nova instalação na vida.

A partir desse ponto, abordamos o manejo da crise sob três perspectivas:

- **Dar continência.** Dar continência significa acolher e suportar angústias, com respeito, sem pressa e sem julgamento. Não se trata de uma psicoterapia formal, e sim do que é esperado de um profissional da saúde atento à situação existencial de seu paciente.
- **Gestão da crise.** Quais providências precisam ser tomadas em relação ao paciente (alívio da dor, ansiedade, insônia), a seus familiares (esclarecimento, orientação) e à equipe assistencial (apoio e auxílio à discriminação e valorização de aspectos emocionais).
- **Psicoterapia de crise.** Um referencial teórico básico e alguns princípios são necessários para a psicoterapia formal, oferecida por um profissional de saúde mental, em situações de crise.

DAR CONTINÊNCIA

Quem pode cuidar da saúde mental do paciente da melhor forma é, quase sempre, seu próprio médico, por meio de atitudes psicoterapêuticas. Na vigência de uma crise, o paciente está desesperado, triste ou fragilizado demais para tolerar a ansiedade gerada por uma psicoterapia de orientação psicanalítica ou para participar ativamente de uma estratégia cognitivo-comportamental.

Ademais, o vínculo estabelecido com seu médico é fundamental. Não seria sábio logo encaminhá-lo para fazer psicoterapia com outro profissional. Em geral, uma psicoterapia indicada sem um período prévio de elaboração junto ao médico é completamente infrutífera e frustrante para todos os envolvidos.

Em termos práticos, ainda que você conte com não mais do que 20 minutos, sua escuta deve ser privilegiada. Privilegiada nos seguintes sentidos:

- **É uma escuta ativa.** Escuta ativa significa estar presente, disponível e conectado ao paciente, sem interrupções, enquanto você ouve, observa seus gestos e deixa seu pensamento, ao mesmo tempo, solto e focalizado no paciente. É um privilégio conhecer nuances do mundo interno de uma pessoa a partir do que ela nos conta de sua vida.
- **É uma escuta calma 1.** Se forem apenas 20 minutos, e principalmente por isso, é melhor estar sentado, com o telefone celular no modo silencioso. Coloque-se ao lado do leito, próximo à cabeceira. Se possível, escolha um horário em que o ambiente da enfermaria esteja calmo.
- **É uma escuta receptiva.** É preciso lembrar que esse é um momento especial para o paciente, pois é um privilégio servir-se da presença de um profissional para falar sobre o que quiser. Não o interrompa e respeite seu silêncio, mas o ajude, com delicadeza, a sair dos silêncios angustiantes, que se prolongam demais.
- **É uma escuta respeitosa.** É preciso respeitar a forma de ser da pessoa, suas concepções e seus valores, seu momento de vida. Não julgue nem rapidamente apazigue, por meio de gestos, chavões ou leituras pretensamente edificantes. Em geral, um apaziguamento na forma de sabedoria exterior, sem que nada brote de dentro do profissional, é totalmente ineficaz e deixa no paciente a sensação de, no fundo, estar em um “papo vazio”.
- **É uma escuta silenciosa.** Jovens profissionais comumente se sentem premidos a dizer algo inteligente, que faça sentido para o paciente e, assim, serem prontamente reconhecidos como capazes. Com o tempo, aprendemos a importância de uma atitude silenciosa. Mantenha em mente as perguntas que lhe surgirem, mas não as faça; é melhor ouvir, “dar continência”.
- **É uma escuta paralisante.** Angustiar-se e, em alguns momentos, não saber o que pensar, ficar paralisado, o que é normal. Isso costuma ocorrer nos minutos iniciais da primeira entrevista ou em momentos mais agudos da interação. Precisamos dessa angústia, afinal, ela é um valioso instrumento de trabalho, para depois transformá-la em pensamentos calmos e aceitáveis.
- **É uma escuta calma 2.** É preciso respeito aos limites, não ser invasivo. Não pergunte o que não precisa ser perguntado, não comente nem emita opiniões apressadas. Nem você, nem o

paciente vão resolver ali, naquela conversa, toda a crise.

- **É uma escuta calma 3.** Não se deve logo encaminhar para uma psicoterapia. Poderia soar como abandono e rejeição. O paciente requer a sua atenção. Em contraposição a isso, um colega médico assim nos disse certa vez, sem se dar conta do paradoxo entre sua fala e sua conduta: “Aqui valorizamos muito o emocional das pacientes e o trabalho das psicólogas; diante da primeira lágrima da paciente, já encaminhamos pra Psicologia!”.

Tentemos uma síntese, ressaltando que:

1. O principal é a “psicoterapia” realizada no interior da relação médico-paciente. Sem essa, nenhuma outra é possível.
2. No fundo, nunca entendemos ao certo o que se passa com o outro. Essa é a maior garantia de que estamos escutando o outro como outro, e não como mera extensão de nossos fantasmas e nossas visões do mundo. Aceitar essa contingência ajuda muito o clínico a recuperar certa serenidade diante do impacto sentido ao escutar um paciente para quem o mundo acaba de desabar. Trata-se de ouvir, de verdade, sem a pretensão de “entender”, mas com atitude de acolhimento e de presença de fato. Isso é fundamental para o sujeito se sentir escutado e para colocar em marcha um processo efetivo de elaboração, que se prolonga mesmo depois que o médico vai embora.

O psiquiatra interconsultor pode auxiliar seus colegas de profissão a dar continência, ao discutir a dinâmica psicológica do paciente diante das circunstâncias que o cercam. Isso pode ser feito de uma maneira simples, durante uma conversa informal, ouvindo atentamente, permitindo desabafos, reconhecendo a dificuldade da situação, apontando formas alternativas de compreender a situação clínica e fazendo sugestões de manejo.

Em situações em que se percebe a dificuldade do médico ou de membros da equipe em lidar com um paciente ou uma situação clínica, o ideal é que o interconsultor aja como um catalisador, preparando a equipe para a tomada de decisões de manejo. Veja a esse respeito a seção Minirreunião clínica, no Capítulo 4. Temos tido sucesso com essas reuniões de 30 minutos, em geral no fim da manhã, com os profissionais da enfermaria.

GESTÃO DA CRISE

Em situações de crise, tudo acaba convergindo para a impressão de que alguma coisa tem de ser feita. Sim, pode ser feita, mas também tem de ser pensada – os dois ao mesmo tempo –, e nem sempre conciliar isso é fácil. Com exceção das eventuais medidas de proteção à vida do paciente com alto risco de suicídio, é preciso ponderar sobre a urgência de fazer algo concreto pela pessoa que atendemos. Deve-se lembrar que o essencial é ouvi-la atentamente, estar ao lado dela.

Para o paciente que sofre de ansiedade, pode-se fazer uma tentativa com técnicas de respiração diafragmática, meditação e relaxamento. Os Quadros 26.2 e 26.3 trazem informações sobre essas técnicas. Em apêndices deste capítulo, há orientações que podem ser feitas ao paciente e treinadas com ele.

QUADRO 26.2

Informações básicas sobre meditação

As técnicas de meditação chegaram até nós por meio da ioga e das religiões orientais, como o budismo e o taoísmo. Entre as adaptações ao estilo de vida ocidental, destaca-se a meditação transcendental. Ela é originária de uma tradição iogue do norte da Índia. Há um aumento das respostas criativas diante de problemas, bem como efeitos positivos no tratamento de várias condições clínicas.^{4,5}

Atualmente, o *mindfulness* vem sendo bastante difundido. O significado desse termo relaciona-se a um estado mental de atenção intencional à experiência vivida no presente, com aceitação e sem crítica ou julgamento. “Parar e estar presente, só isso.” A técnica supõe dois componentes básicos: (1) a autorregulação da atenção, ou seja, manter-se concentrado na experiência fenomenológica imediata, incluindo mente e corpo, e (2) uma orientação aberta à experiência, que supõe curiosidade e aceitação incondicional. Envolve também a observação de eventos internos, como emoções, pensamentos e padrões mentais, que se chama metacognição ou descentralização.^{6,7}

O treinamento básico de *mindfulness* é realizado em oito semanas, com 2h30min a cada semana, sob a orientação de um professor, e com práticas diárias em casa. Em *Research on Mindfulness*,⁸ encontra-se uma lista de condições clínicas em que a técnica se demonstrou útil aos pacientes.

QUADRO 26.3

Duas técnicas de relaxamento

As técnicas de relaxamento começaram no Ocidente com os trabalhos de Johaness H. Schultz (relaxamento autógeno) e Edmund Jacobson (relaxamento progressivo).

Schultz impressionou-se com os métodos da ioga hindu, em que, por meio de exercícios de concentração, o praticante consegue exercer certa influência sobre o sistema nervoso autônomo.

Jacobson foi um médico fisiologista que trabalhava em Harvard, no início do século XX. Antecipando-se a conhecimentos que viriam mais tarde pelas pesquisas sobre *biofeedback*, postulou que a aprendizagem do relaxamento muscular, região por região, progressivamente, pode colocar em repouso, do ponto de vista mental, territórios do cérebro correspondentes às partes do corpo assim relaxadas. Do ponto de vista clínico, observam-se diminuição da ansiedade, às vezes, sonolência, lassidão, diminuição da pulsação, respiração mais lenta e discreta, queda da pressão arterial.⁹

Em curto prazo, psicofármacos podem ser usados, tendo-se em mente os seguintes objetivos: reduzir a ativação do paciente durante o dia e ajudá-lo a dormir à noite. A ansiedade e a inquietude motora, além da dor e a insônia, aumentam a sensação de desespero e, em alguns casos, o risco de suicídio.

O psiquiatra que prescreve medicamentos não reagirá à angústia repentina do paciente, da equipe assistencial ou dos familiares nem mudará, sob pressão e intempestivamente, o esquema medicamentoso recentemente instituído. No entanto, é imprescindível esclarecer o significado e os determinantes de uma piora imprevista. Também é importante verificar, junto ao médico assistente, se o controle da dor pode ser melhorado.

Reafirmar a disponibilidade, conseguir que a medicação seja mantida por mais um determinado tempo antes de fazer mudanças repentinas, promover eventual melhora da analgesia e dar uma palavra final sobre a boa expectativa em relação ao tratamento costumam renovar a esperança de pacientes e familiares.

Insegurança, cansaço e desgaste emocional costumam acometer os familiares do paciente internado. Como a rotina da família muda substancialmente, alguns conflitos vêm à tona. Todos, incluindo a pessoa a ser cuidada, estão passando por uma fase de adaptação à nova condição. Isso demanda, do profissional, disponibilidade de tempo e capacidade para gerenciar também a crise da família.

PSICOTERAPIA DE CRISE

No hospital geral, indica-se a psicoterapia para pessoas que reagem à doença aguda com insegurança desproporcional, fantasias devastadoras, medo, angústia e sintomas depressivos ou ansiosos. Quando a condição emocional do paciente estiver demasiadamente perturbada ou o médico assistente atingir seu limite para manejar uma situação de crise, é necessária a psicoterapia de crise, provida por um profissional treinado.

A psicoterapia de crise – alguns talvez prefiram chamá-la de psicoterapia “na” crise – deve ser orientada para as circunstâncias pessoais e sociais emergentes do paciente. Em uma abordagem emergencial e de curto – ou curtíssimo – prazo, muitas vezes apenas enquanto durar o período de internação hospitalar.^[NT]

O objetivo é reduzir a pressão psicológica. Não há ênfase em mudanças de personalidade ou na abordagem de conflitos inconscientes. Procura-se dar continência às demandas emocionais do paciente. Envidamos esforços para:

- reforçar mecanismos de defesa adaptativos e aspectos sadios da personalidade
- afastar pressões ambientais que estejam incrementando a crise
- adotar medidas que visem ao alívio de sintomas
- auxiliar no fortalecimento da autoestima do paciente
- se possível, favorecer habilidades adaptativas
- se necessário, motivar para a continuidade da psicoterapia após a alta hospitalar

No contexto de enfermarias de um hospital geral, algumas adaptações técnicas são necessárias.¹⁰

O lugar da consulta geralmente não oferece a privacidade necessária, mas isso não deve ser um impedimento. Se o quarto for coletivo, deve-se dirigir-se com o paciente, se possível, até um lugar que ofereça mais privacidade (às vezes, basta um canto de corredor com duas cadeiras). Se o paciente não puder deambular, sente-se à cabeceira da cama, falando mais baixo. Às vezes, o colega de quarto pode não se importar em se afastar por alguns momentos.

O tempo de cada sessão geralmente varia de 15 a 30 minutos e sempre deve estar adaptado a duas circunstâncias: a condição do paciente e a rotina dos cuidados hospitalares. É preciso ser flexível. A interrupção pela chegada de outros profissionais e os adiamentos de sessões, decorrentes de ações médicas, não devem ser encarados como “quebra de *setting*”, devem ser vistos como parte deste, cuja principal característica é a flexibilidade adaptativa.

Não custa lembrar que é aconselhável livrar-se da obsessão de encontrar explicações psicológicas para os sintomas. De modo geral, devem ser consideradas as fontes de estresse mais imediatas às quais o paciente está reagindo e suas preocupações conscientes em relação a elas. Os eventuais *insights* psicodinâmicos devem auxiliar o raciocínio do profissional, orientar o manejo do caso e nunca se transformar em interpretações para o paciente ou em formulações rebuscadas para a equipe assistencial.^[NT]

Há necessidade, também, de ter conhecimentos básicos sobre a doença sofrida pelo paciente, bem como sobre as investigações e tratamento a que ele está submetido. Isso pode ser obtido se o profissional de saúde mental se mantiver próximo da equipe assistencial e participar, sempre que possível, das discussões clínicas.

Referencial teórico

Algumas características da psicoterapia de crise em muito se avizinham do que se convencionou chamar de psicoterapia de apoio. A técnica e o referencial teórico da psicoterapia de crise no âmbito do hospital geral são ecléticos. Mais do que opção do terapeuta, poderíamos dizer que se trata de uma necessidade. As ações psicoterapêuticas conformam um manejo flexível e realista, adaptado ao *setting* hospitalar.

As diferentes escolas de psicoterapia têm perspectivas que não são mutuamente excludentes no que diz respeito à crise. Elas compartilham um núcleo comum relacionado às reações do ser humano diante de um sofrimento agudo. Não raramente, pode-se olhar o sujeito sob várias dessas perspectivas, ainda que uma ou outra favoreça a compreensão da pessoa ou de uma situação clínica em particular.

No âmbito do hospital geral, e notadamente para pacientes internados, a experiência de nosso grupo de interconsulta combina o entendimento psicodinâmico com intervenções cognitivas e comportamentais. No entanto, ao sintetizarmos dessa maneira, corremos o risco de ofuscar contribuições de outras escolas de psicoterapia que julgamos igualmente valiosas para a psicoterapia de crise.

Destacamos Carl Rogers, Alfred Benjamin e Irvin Yalom. Os dois últimos, é de se ressaltar, também reconhecem em seu trabalho a influência rogeriana. Os livros desses três autores se inscrevem na psicologia humanista, uma perspectiva que se sustenta a partir da fenomenologia e do existencialismo. A abordagem dessa escola de psicoterapia é bem útil ao profissional da saúde que procura se valer de uma sustentação teórica para atender pessoas em crise.

Ao criar a psicoterapia centrada no cliente e a abordagem não diretiva, Carl Rogers¹² ofereceu importante alternativa às psicoterapias freudianas e behavioristas, então dominantes entre as décadas de 1950 e 1960.^[NT] Sua técnica procurava oferecer uma atmosfera terapêutica de consideração positiva incondicional, afeto e inquestionabilidade. Com isso, acreditava, o paciente teria as condições necessárias para o crescimento pessoal e a realização de seu potencial.

Alfred Benjamin,¹³ no fim da década de 1960, escreveu uma obra-prima em forma de livro didático e sincero, que dialoga com o leitor, *A entrevista de ajuda*. O número de edições (reimpressões) brasileiras ultrapassa duas dezenas. Adotado no programa teórico do Ambulatório de Crise do Hospital de Clínicas da Universidade Estadual de Campinas,¹⁴ o livro *A entrevista de ajuda* sempre produz discussões enriquecedoras e a todos impregna com o entusiasmo de fazer melhores entrevistas:

Em qualquer caso, a questão fundamental para o entrevistador deve ser sempre a seguinte: qual será o melhor modo de ajudar essa pessoa? Não estou certo de poder definir ajuda satisfatoriamente para mim mesmo. Essa talvez seja uma razão da

existência deste livro. Ajudar é um ato de capacitação. O entrevistador capacita o entrevistado a reconhecer, sentir, saber, decidir, escolher se deve mudar. Esse ato de capacitação exige doação da parte do entrevistador. Precisa dar uma parte de seu tempo, de sua capacidade de ouvir e de entender, de sua habilidade, conhecimento e interesse – parte de si mesmo. Se essa doação puder ser sentida pelo entrevistado, o ato de capacitação encontrará receptividade.¹³

A postura clínica de Benjamin reflete-se na sua formulação quanto à existência de três modos alternativos de se compreender uma pessoa:^[NT]

Um deles é saber sobre ela. Leio sobre ela, ouço falarem dela, participo da discussão sobre ela em reuniões de equipe – eu sei a respeito dela. Compreendo-a, por assim dizer, por meio dos olhos dos outros, e não por meio dos meus ou dos seus.

[...]

A segunda maneira de se compreender uma pessoa é compreendê-la não por meio dos olhos dos outros, mas por meio dos nossos... [A compreensão] é em meus termos, conforme meus conhecimentos, minha experiência, minha imaginação.

[...]

A terceira é a mais significativa, embora simultaneamente a mais difícil. Trata-se de compreender com a outra pessoa... É necessário deixar tudo de lado, menos nosso senso comum de humanidade, e somente com ele tentar compreender com a outra pessoa como ela pensa, sente e vê o mundo ao seu redor. Significa nos livrarmos de nossa estrutura interna de referência e adotar a do outro.¹³

Irvin Yalom,¹⁵ um autor de leitura estimulante para quem começa a se interessar pela relação médico-paciente e psicoterapia, registrou sua experiência como psiquiatra e psicoterapeuta em várias obras científicas e de ficção. Tornou-se respeitado na área de psicoterapias individual e grupal, além de ter-se tornado um escritor famoso. Seus livros refletem sua postura profissional:

Se minhas sessões terapêuticas fossem gravadas, muitas vezes o espectador poderia procurar em vão por longas discussões explícitas sobre morte, liberdade, significado ou isolamento existencial. Tal conteúdo existencial pode se evidenciar somente para alguns (mas não para todos os) pacientes, em alguns (mas não em todos os) estágios da terapia. De fato, o terapeuta eficiente nunca deveria tentar forçar uma discussão em nenhum terreno de conteúdo: a terapia não deve ser impulsionada pela teoria, mas sim pelo relacionamento.¹⁵

Recomendo enfaticamente que deixe que seus pacientes sejam importantes para você, que deixe que eles entrem na sua mente, que o influenciem, que o modifiquem – não esconda isso deles.¹⁵

Alguns princípios e sugestões

Inicialmente, é importante tomar como foco o conteúdo (frustração, conflito, necessidade) expressado pela pessoa. De modo geral, você deve identificar as fontes de estresse mais imediatas às quais o paciente está reagindo. O atendimento de crise exige isso. O “foco” está sempre no que é expresso pela pessoa, e não em uma suposta “eleição” – prévia e racionalmente delimitada – do que seria importante tratar com o paciente, como se defende na psicoterapia focal.^[NT]

O intuito é ajudar o paciente a se expressar e a ampliar a visão a respeito de sua problemática, em um nível consciente. Além disso, é importante atentar para o conteúdo latente do que se ouve, aos sentimentos indiscriminados e conflituosos, às falsas crenças, aos pensamentos automáticos que impedem visão mais ampla ou alternativa, como se dão os relacionamentos mais importantes. Tudo isso, se for o caso, poderá ser abordado mais tarde, com calma, quando houver maior capacidade para a reflexão.

O Quadro 26.4 traz alguns dos princípios da psicoterapia de crise. A lista certamente não está completa, uma vez que ela se encontra aberta à experiência clínica e ao referencial teórico predominante de cada profissional.

QUADRO 26.4

Alguns princípios da psicoterapia de crise

- Levar em conta sua disponibilidade interna
- Reservar tempo na agenda, pois as crises surgem inesperadamente
- Ouvir com atenção, paciência e sem julgar
- Preparar-se para transfusão de esperança e de recursos egoicos
- Observar reações emocionais e distorções cognitivas
- Considerar os sentimentos que o paciente provoca em você e em que papel este o coloca
- Respeitar silêncio e choro, mas ajudar, com delicadeza, o paciente a sair deles
- Resumir o que compreendeu até dado momento e solicitar algum esclarecimento
- Se possível, explorar como o paciente já enfrentou e superou crises (*coping*)
- Não se esquecer de avaliar o grau de risco de suicídio
- Identificar e obter o apoio de pessoas significativas
- Psicofármacos devem ser usados regularmente para: diminuir ansiedade e inquietude, garantir noite de sono, contribuir na redução da dor
- Diante do exagero das urgências, propor moratória e objetivos escalonados
- Revisar um plano de segurança
- Compartilhar sua angústia com colega ou supervisor
- Se presentes, discutir dilemas éticos com o paciente e outros relacionados
- Preparar o paciente, se for esse o caso, para uma psicoterapia de longo prazo

Escuta ou solução de problemas?

A resposta mais adequada a essa pergunta é combinar de maneira diferente as duas posturas, de acordo com o momento do paciente e a situação clínica. Deixar o paciente se expressar livremente e, simplesmente, ouvi-lo já tem valor terapêutico. Dependendo do paciente e da situação, o profissional deve agir de forma distinta, ser mais ativo, fazendo mais perguntas e propostas de diálogo.

Um exemplo disso é o estudo de Truax e Carkhuff.¹⁷ O estilo de acolher pacientes potencialmente suicidas foi analisado a partir da gravação de 617 chamadas telefônicas feitas a dois centros canadenses de prevenção do suicídio. Concluiu-se que uma postura sem julgamento e não diretiva (escuta ativa) foi eficaz na redução de intenção suicida em pessoas que telefonavam pela primeira vez. Em pessoas que telefonavam frequentemente, uma abordagem mais ativa (solução de problemas) produziu mais benefícios.¹⁷ O Quadro 26.5 resume esses dois estilos de entrevista.

QUADRO 26.5

Principais características de dois estilos de entrevista observados em chamadas telefônicas feitas a centros de prevenção do suicídio

Escuta ativa	Solução de problemas
--------------	----------------------

Aliança terapêutica

O vínculo que se estabelece entre as duas pessoas assegura a comunicação e possibilita o processo de ajuda.

Avaliação de risco de suicídio

Tarefa obrigatória em todo telefonema. As respostas dadas a perguntas básicas orientam de forma diferente a ação do entrevistador.

Escuta ativa: O profissional escuta com calma e respeito e não conduz a conversa. Sentir-se compreendido, perceber que alguém se importa, acalma o paciente e o ajuda a compreender a situação.

Descoberta de soluções: Ao compreender melhor a situação, o paciente muda seu ponto de vista e, por si, encontra soluções.

Principais intervenções:

- Postura acolhedora
- Perguntas gerais e raras
- Resume compreensivelmente o relato
- Sugere reformulações de ponto de vista
- Perguntas sobre sentimentos e emoções
- Reflexão sobre sentimentos ambivalentes
- Incentivo para busca de soluções

Investigação: O profissional investiga os principais problemas enfrentados pelo paciente, pergunta mais e é mais diretivo. Junto com o interlocutor, eleger um problema principal e focaliza-se nele.

Busca por recursos: O profissional identifica novas possibilidades de solução e inicia, com o paciente, busca de recursos para solução dos problemas.

Principais intervenções:

- Postura investigativa
- Perguntas diretas sobre os problemas
- Fatores precipitantes são explorados
- Aconselhamento, sugestão
- Perguntas sobre recursos externos de ajuda
- Elaboração de um plano de ação

Fechamento:

Ao término do telefonema, o paciente sente-se menos só, menos ansioso em relação a sua situação, ganha esperança ao perceber os recursos (pessoais e externos) com que pode contar. Tentará encontrar outras soluções que não o suicídio.

Fonte: Com base em Mishara e colaboradores.¹⁸

Moratória e objetivos escalonados

No contexto de uma crise psicológica, é aconselhável postergar decisões importantes. Nisso, o psicoterapeuta se vale de sua autoridade. Uma moratória psicológica deve ser acordada entre profissional e paciente. Por exemplo: até determinada data, não me obrigarei a dar uma solução para tal problema; até lá, procurarei me fortalecer e me proteger.

Em uma tentativa de conter a ansiedade do paciente que quer melhorar rápido demais, ou para contê-lo na ânsia de, rapidamente, chegar a soluções de seus problemas, costumamos dizer algo do tipo: “se você tivesse sido atropelado por um caminhão e sobrevivesse, já imaginou como seria sua recuperação? Então, de alguma forma, você foi atropelado, agora, por um caminhão existencial”. Esse é o tipo de intervenção que pode permitir a passagem da catástrofe à crise.

Os objetivos devem ser escalonados e passíveis de serem alcançados no curtíssimo, curto, médio e longo prazos (respectivamente, por exemplo: uma semana, dois meses, seis meses e um ano). Não podem ser ambiciosos, já que a impossibilidade de os cumprir pode baixar ainda mais a autoestima. Deve-se ajudar o paciente nisso. Todavia, é preciso ser realista, visto que a crise pode estar inserida em um contexto de graves dificuldades pessoais, familiares e sociais.

Disponibilidade interna e na agenda

Para lidar com uma situação de crise, além de capacidade pessoal, é necessário ter disponibilidade interna. Trata-se de um espaço psíquico preservado e calmo, aberto a interações, por meio do qual é possível acolher uma pessoa fragilizada. Essa disponibilidade normalmente varia dependendo do momento de vida e das pressões que enfrentamos.

O atendimento de crise requer disponibilidade na agenda. Não é raro que a próxima conversa precise ser no dia seguinte, no máximo, em dois ou três dias. Se sempre trabalhar com a agenda lotada, aceitando encaixes, o profissional não terá condições satisfatórias para atender uma pessoa em crise suicida. Isso ocorre devido ao pouco tempo que lhe resta e, provavelmente, à exígua disponibilidade interna que a rotina de trabalho lhe deixa.

Além disso, não se deve cometer o equívoco de, em uma temporada aparentemente calma, fazer encaixes de casos de menor gravidade e urgência nos espaços reservados para atendimentos de crise. É preferível ocupá-los, por exemplo, com leitura, arrumação de gavetas, discussão clínica ou com tempo mais amplo para uma refeição.

Estamos conscientes do caráter potencialmente angustiante dessas ideias e sugestões, principalmente ao considerarmos a sobrecarga de trabalho nos primeiros anos da profissão e em grande parte dos serviços públicos de saúde mental. No entanto, é preciso ressaltar que lidar com crises exige, além de disponibilidade interna, horários que permaneçam reservados para atendimentos emergenciais.

Portanto, se você deseja ser um terapeuta de crise, responder a esse caráter de urgência faz parte do seu trabalho. A chegada de um paciente em crise não deveria representar um tumulto indesejado e incontornável.

Cuidar, cuidar-se

Ainda que imerso em tensão, o acompanhamento de pessoas que enfrentam catástrofes ou crises existenciais costuma enriquecer a experiência de vida e exercer um efeito positivo na identidade profissional e, também, na identidade pessoal.

Enfatizamos que não se trata de saber absolutamente tudo, amar todos e curar todos. Essas são as três armadilhas do narcisismo.² A menos que essas propensões sejam elaboradas, o médico será tomado por um sentimento de desamparo e desalento e tentará resolver seu dilema por meio de ações mágicas ou destrutivas.

Para finalizar, retomemos aqui o depoimento do médico de 31 anos abordado no Capítulo 3:

Se houvesse um órgão chamado “paciência” no ser humano, eu diria que retiro a minha capacidade de cuidar do fundo da minha paciência. Acho que a famosa compreensão do outro, no meu caso, é o resultado do exercício de uma paciência capaz de esperar o momento em que o sujeito do cuidado esteja pronto para tal. Sem isso, a meu ver, o cuidado torna-se invasivo, uma vez que não se trata de impor uma moral de uma boa conduta de vida, mas sim de sentir o momento em que o outro precisa de ajuda, estando disposto a ser ajudado. Nesse ponto entra a disponibilidade.

Aqui é importante ressaltar que a disponibilidade de cuidar do outro nunca, no meu caso, é maior do que a disponibilidade de cuidar de mim (será que isso é um contrassenso?). Somente assim tenho forças para cuidar continuamente se necessário, pois me preservo de exagerar e faço pausas nessa atividade, que sem precaução alguma é extenuante.

São nessas pausas para cuidar de mim (ficar com minha esposa, estudar, ler história e sociologia, jogar, e outras coisas das quais eu gosto) que encontro tempo para refletir sobre tudo, inclusive sobre meu cuidado. É assim, tomando conta da minha capacidade de cuidar, que mantenho as forças para continuar com essa tarefa. Tento cuidar-me para poder desenvolver bem o meu trabalho.



O cuidar de si para cuidar dos outros e o tomar conta da própria capacidade de cuidar são fundamentais para quem trabalha com crises humanas. É importante reconhecer os próprios vieses, aprender a interpretar as próprias reações e estar atento ao momento de pedir ajuda. Pode ser durante uma troca de ideias com colegas ou por meio da supervisão com um profissional experiente.

Um recurso que costuma ser bem valioso na rotina dos serviços assistenciais é a realização de reuniões clínicas rotineiras. Estas não são administrativas, que, geralmente, já são realizadas com frequência e duração excessivas, mas verdadeiras e boas reuniões clínicas. Nesses momentos, todos param para refletir sobre a prática do dia a dia e sobre as repercussões psíquicas que o atendimento da crise suicida mobiliza nos profissionais.

É imprescindível tomar cuidados extras em prol da própria saúde mental. São coisas tão simples quanto essenciais: reservar tempo de qualidade para si e para a família; retomar antigos costumes que costumavam trazer alegria e paz; limitar o número de pacientes que provocam sobrecarga emocional, fazer pausas para reflexão; contar com psicoterapia pessoal e com supervisão; organizar com os colegas um grupo de estudos e um encontro rotineiro, a fim de discutir situações clínicas mais difíceis ou angustiantes.

REFERÊNCIAS

1. Botega NJ. Crise suicida: avaliação e manejo. Porto Alegre: Artmed; 2015.
2. Maltzberger JT, Buie DH. Countertransference hate in the treatment of suicidal patients. *Arch Gen Psychiatry*. 1973;30(5):625-33.
3. Gabbard GO. A contemporary psychoanalytic model of countertransference. *J Clin Psychology*. 2001;57(8):983-91.
4. Forem J. Transcendental meditation: Maharishi Mahesh Yogi and the science of creative intelligence. New York: Bantam Books; 1976.
5. Goleman D. A arte da meditação. Rio de Janeiro: Sextante; 1999.
6. Cebolla I, Marti A, Garcia-Campayo J, Demarzo M. Mindfulness e ciência: da tradição à modernidade. São Paulo: Palas Athena; 2016.
7. Hayes-Skelton S, Graham J. Decentering as a common link among mindfulness, cognitive reappraisal, and social anxiety. *Behav Cogn Psychother*. 2013;41(3):317-28.
8. Mindfulnet.org [Internet]. Research on mindfulness. Mindfulnet; c2017 [capturado em 19 jan. 2017]. Disponível em: <http://mindfulnet.org/page4.htm>.
9. Geissmann P, Bousingen RD. Métodos de relaxação. São Paulo: Loyola; 1968.
10. Furlanetto LM. Estratégias psicoterapêuticas em interconsulta. *Rev Bras Psicoter*. 2006;8(1):87-98.
11. Botega NJ, Silveira IU, Mauro MLF. Telefonemas na crise: percurso e desafios na prevenção do suicídio. Rio de Janeiro: ABP; 2010.
12. Rogers C. Psicoterapia y relaciones humanas. Madrid: Alfaguara; 1971.
13. Benjamin A. A entrevista de ajuda. São Paulo: Martins Fontes; 2008.
14. Botega NJ, Turato ER, Giglio JS, Laurito Jr JB, Jacintho ACA, Santos Jr A. Atendimento de crise no ambulatório de psiquiatria do Hospital de Clínicas da Unicamp. *Rev Bras Psicoter*. 2011;13(3):63-9.
15. Yalom, ID. Os desafios da psicoterapia: reflexões para pacientes e terapeutas. Rio de Janeiro: Ediouro; 2006.
16. Guilliéron E. As psicoterapias breves. Rio de Janeiro: Zahar; 1986.
17. Truax CB, Carkhuff RR. Towards effective counseling and psychotherapy: training and practice. Chicago: Aldine; 1967.
18. Mishara BL, Chagnon F, Daigle M, Balan B, Raymond S, Marcoux I, et al. Comparing models of helper behavior to actual practice in telephone crisis intervention: a silent monitoring study of call to the U.S. 1-800-SUICIDE network. *Suicide Life Threat Behav*. 2007;37(3):291-307.

[pragmático] Recomendamos a leitura dos seguintes capítulos, que conformam, nesta obra, uma base de Psicologia Médica: Capítulo 2, O paciente diante da doença e da hospitalização; Capítulo 3, O médico e o cuidar; Capítulo 4, Pacientes-problema: um impasse; Capítulo 5, Relação entre médicos; Capítulo 6, Saúde mental dos profissionais da saúde; Capítulo 7, Interconsulta psiquiátrica: visão psicodinâmica; e Capítulo 27, A morte e o morrer: aspectos psicodinâmicos.

[proteger] Os Capítulos 2 e 4 aprofundam a temática dos mecanismos de defesa e do *coping* como recursos do eu para suportar as ameaças de desprazer insuportável e de desestruturação.

[pacientes] Relembramos que essa couraça de proteção pode ser um dos sinais da síndrome de esgotamento profissional (*burnout*). Outros comportamentos podem estar presentes nesse quadro, como absenteísmo, irritabilidade com pacientes e colegas, humor negro, consultas rápidas e tendência a usar rótulos depreciativos. Há também os sintomas somáticos (fadiga, dores) e psicológicos (falta de concentração, depressão, ansiedade, rigidez, desinteresse, negativismo, baixa autoestima). As vulnerabilidades de profissionais da saúde são abordadas no Capítulo 6, Saúde mental dos profissionais da saúde.

[emocionais] Dois conceitos fundamentais da psicanálise, transferência e contratransferência, são descritos no Capítulo 2: “no encontro terapêutico, à semelhança da relação entre pai e filho durante a infância, o médico passa a ser depositário de fantasias repletas de elementos mágicos que configuram a transferência”. Em resposta – à contratransferência –, “o inconsciente do analista (médico) entenderia o de seu paciente”. A contratransferência não é uma percepção em sentido estrito, e sim um indício de grande significado semiológico, não só para o psicanalista como também para os profissionais da área da saúde em geral.^{2,3}

[depressão] O Capítulo 15, Depressão, aborda as nuances do diagnóstico de episódio depressivo no contexto de um hospital geral. Alguns sintomas da doença de base, motivo da internação, podem se confundir com os sintomas clássicos da depressão. Ademais, pode haver dor, noites mal dormidas, cansaço e medicamentos que causam sintomas depressivos. Tudo isso dificulta o diagnóstico de depressão, o qual demanda um conjunto de detalhes da anamnese e da observação clínica.

[questionamentos] A situação encontrada faz parecer que uma “bomba-relógio” se encontra armada, como descrevemos no Capítulo 7, sobre a psicodinâmica da interconsulta.

[hospitalar] Em vários projetos realizados no Hospital das Clínicas da Universidade Estadual de Campinas (HC Unicamp), usamos a estratégia de fazer telefonemas rotineiros após a alta hospitalar para pessoas internadas por tentativa de suicídio, dependentes de nicotina ou de álcool e depressão. Os telefonemas, em si, não foram “a” proposta de tratamento. Tinham o objetivo de incentivar a busca e a manutenção do tratamento em serviços ambulatoriais da rede pública.¹¹ De modo geral, essas iniciativas foram muito frutíferas e ilustraram como o serviço de interconsulta psiquiátrica pode ter um papel mais proativo. Demonstram, também, o efeito terapêutico desse dispositivo de atenção que possibilitou a muitos pacientes dar um sentido ao que lhes havia ocorrido.

[equipe assistencial] Nos casos de queixas corporais sem explicação médica (ver Cap. 17), a expressão de um conflito no espaço corporal já é uma maneira de “expelir” a dor do espaço mental, o que leva muitos pacientes a resistir a uma abordagem psicoterápica tradicional. Então, mais uma vez, fica clara a importância do trabalho “psicoterapêutico” do próprio médico junto a seu paciente.

[Rogers] Carl Rogers, psicólogo norte-americano, acreditava que alguns indivíduos reprimem suas próprias necessidades, a fim de receber consideração positiva condicional de figuras de autoridade. Em consequência, passam a ter baixa autoestima e a se sentir incapazes de autorrealização.

[pessoa] Provavelmente, Alfred Benjamin esteja se referindo àqueles momentos de interação extremamente gratificantes, em que terapeuta e paciente sentem que estão compreendendo juntos, trabalhando juntos, “acasalados”. No entanto, enfatizamos a noção de que tão – ou mais – importante que “compreender” um paciente é a atitude de tolerar o “não compreender” o paciente, aceitá-lo em sua “estranheza”, em sua diferença radical.

[focal] Nas psicoterapias breves, ou focais, como são igualmente chamadas, o *foco* diz respeito a temas ou conflitos específicos, definidos no início da psicoterapia, e está ligado a uma hipótese psicodinâmica construída em conjunto com o paciente.¹⁶

APÊNDICE 1

Respiração diafragmática e meditação (orientações para os pacientes)

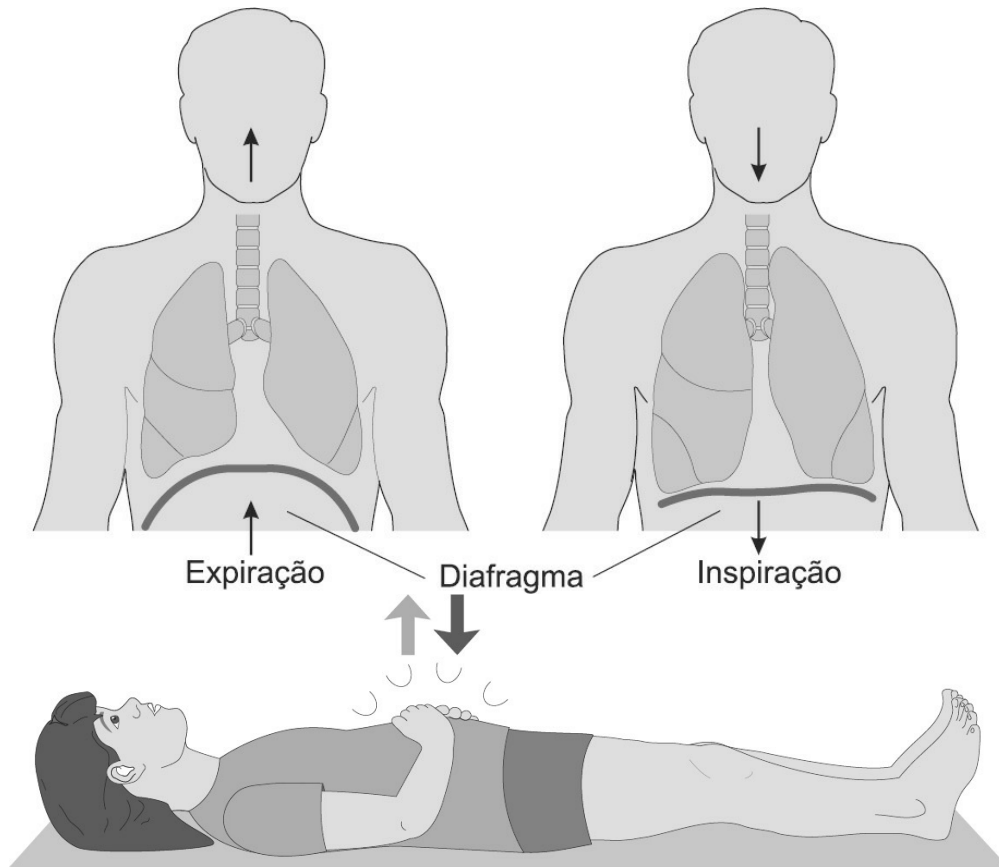
Quando estamos ansiosos, acabamos respirando “errado”, ou seja, rápido e sem boa expansão do tórax. Essa respiração superficial, pouco eficiente, acarreta baixa oxigenação do cérebro e alterações do pH sanguíneo. Em consequência, sensações desagradáveis, às vezes alarmantes, começam a aparecer, como tontura, formigamento e aceleração do coração. O mal-estar costuma levar a mais preocupações com o que está ocorrendo, a mais ansiedade, podendo chegar a uma crise de pânico.

A respiração pode ser o primeiro passo para diminuir o estresse e se acalmar. Também é valiosa para quem sofre de insônia e de transtorno de pânico. Tem esse nome porque se vale de uma contração vigorosa do músculo diafragma, que se contrai para expandir os pulmões (inspiração) e aumentar a entrada de ar. Na expiração, o diafragma relaxa-se (“sobe”), comprimindo os pulmões e expulsando o ar.

Na respiração diafragmática, procura-se:

- a máxima expansão dos pulmões
- uma respiração lenta e compassada
- movimentar mais o abdome do que o tórax

COMO FAZER A RESPIRAÇÃO DIAFRAGMÁTICA



- Deite-se, ou sente-se, confortavelmente.
- Coloque uma das mãos sobre o abdome e veja como ele pode se mover, para cima e para baixo, ao ritmo da respiração. Você pode imaginar que está enchendo uma bexiga dentro de sua barriga.
- Feche os olhos e concentre-se em sua respiração.
- Procure afastar preocupações; concentre-se no fluxo de ar, que entra mais frio e sai aquecido.
- Ao inspirar, conte mentalmente até quatro.
- Retenha um pouco o ar (conte até dois mentalmente), mantendo a barriga e os pulmões cheios.
- Expire lentamente pela boca, contando até cinco, para esvaziar completamente o pulmão.
- Reinicie os movimentos após reter os pulmões vazios por dois tempos.

MEDITAÇÃO

Há um método simples de meditação que qualquer pessoa pode praticar. O ideal é que se pratique duas vezes ao dia, com duração de 20 minutos cada sessão.

Sente-se confortavelmente em uma cadeira de espaldar alto, colocando as mãos sobre as coxas, com o quadril na mesma altura que os joelhos ou um pouco mais abaixo. A coluna deve se manter reta em qualquer das duas posições.

Feche os olhos e mantenha a atenção plena na respiração. Respira-se pelo nariz, naturalmente, sem se preocupar com o ritmo, que aos poucos vai se tornando calmo. A atenção deve ser focalizada no ar que entra e no ar que sai, procurando-se ouvir os ruídos internos do corpo durante o ato de respirar.

Se surgir algum pensamento diferente – e eles vão mesmo surgir –, deve-se observá-lo como se observa um objeto qualquer boiando em um riacho ao sabor da correnteza, isto é, não deve ser feito nenhum esforço para afugentar o pensamento. Depois que ele passar, volta-se novamente a atenção para o movimento do ar que entra e do ar que sai dos pulmões.

Após 20 minutos de prática, deve-se voltar lentamente à atividade rotineira, procurando-se manter o mesmo estado de calma anterior que a meditação produziu.

Sugestões adicionais

- **Mentalização de intenção.** Antes de se iniciar a meditação propriamente dita, você pode mentalizar uma intenção que se refira a seu próprio bem-estar, como, por exemplo, melhora do estado de saúde ou resolução de algum problema pessoal. Ao fim da meditação, direcione uma nova intenção compassiva para outra(s) pessoa(s) que lhe pareça(m) necessitada(s) de alguma ajuda. Essa prática adicionada à meditação tem o objetivo de desenvolver a autocompaixão e a compaixão pelo outro.
- **Comer em atenção plena.** Focalizar a atenção somente na experiência do comer, nas sensações e nos sentidos enquanto come.
- **Atenção em atividades cotidianas.** Focalize a atenção em atividades que normalmente são realizadas automaticamente, como tomar banho, dirigir, etc.
- **Body scan.** Meditar na contemplação das sensações corporais. Por exemplo, começar pelos pés até chegar à cabeça.
- **Prática dos três minutos.** Trata-se de uma meditação rápida, passível de ser realizada em qualquer momento do dia. Tem três fases: tomar consciência (de pensamentos, emoções, sensações, etc.); trazer a atenção ao presente; ampliar a atenção para todo o corpo.

APÊNDICE 2

Relaxamento progressivo (orientações para o paciente)

Deite-se de costas com os olhos fechados. As pernas devem estar entreabertas, e os pés, voltados para fora. As palmas das mãos devem estar voltadas para dentro, mas sem forçar a musculatura dos braços e punhos, e os dedos, semifletidos.

A contração muscular corresponde a um movimento de flexão vigoroso de um segmento corporal, e a descontração, a uma extensão. Devem ser realizados lentamente e com a máxima conscientização possível.

A contração deve sempre ser feita na inspiração, e a descontração, na expiração. A descontração será mais lenta que a contração, como na Respiração Diafragmática (Apêndice 1 deste capítulo).

Cada um dos seguintes exercícios deve ser repetido três vezes, antes de se passar para o seguinte. A série completa dura aproximadamente 20 minutos. Idealmente, o relaxamento deve ser feito todos os dias, pelo menos uma vez.

- **Contração do braço** – Durante a inspiração, flexionar lentamente o braço direito fechando a mão como se fosse dar um soco, contraindo braço, punho e mão vigorosamente. Durante a expiração, estender e descontrair o braço, voltando à posição de repouso. Repetir três vezes. Após alguns segundos de repouso, fazer o mesmo exercício com o braço esquerdo, repetindo-o três vezes.
- Os exercícios seguintes deverão ser repetidos três vezes, **com contração na inspiração e descontração na expiração**:
- **Contração das pernas, com flexão dos pés** – Fazer uma flexão vigorosa do pé direito, elevando o hálux (dedão) em direção ao rosto, na inspiração. Estender o pé e descontrair todo o membro na expiração. Fazer o mesmo exercício com a perna esquerda.
- **Contração das pernas, com extensão dos pés** – Fazer uma extensão do pé direito e flexão dos artelhos, semelhante ao movimento que as bailarinas fazem no *ballet* clássico. Contrair também vigorosamente a panturrilha (barriga da perna). Descontrair lentamente na expiração. Fazer o mesmo exercício com a perna esquerda.
- **Contração dos glúteos** – Contrair vigorosamente os glúteos, como na posição de “sentido!” dos soldados. Descontrair suavemente, na expiração.
- **Peito para frente** – (em direção ao teto) no mesmo estilo que os militares fazem na posição “sentido”, mas exagerando a contração. Depois, descontrair a musculatura lentamente.
- **Levantamento dos ombros** – Levantar os ombros, simultaneamente, tentando encostá-los nas orelhas. Voltar ao repouso lentamente, acompanhando a expiração.
- **Flexão do pescoço** – Flexionar o pescoço, colocando o queixo junto ao peito. Voltar à posição inicial, na expiração, lentamente.
- **Extensão do pescoço** – Estender a cabeça para trás, procurando aproximar a parte mais alta da cabeça do leito. Voltar lentamente à posição normal, na expiração.

- **Contração da face** – Aqui temos três variedades. Pode-se escolher uma delas, ou mesmo fazer as três. Na inspiração, contração; na expiração, volta-se à posição normal, suavemente:
 - **Riso sardônico** – Fazer uma careta, forçando as rimas labiais em direção às orelhas.
 - **Focinho de Quati** – Usamos essa analogia para dar ideias da contração de todos os músculos da face em torno do nariz, tentando imitar o focinho desse animalzinho.
 - **Movimento facial iogue** – Consiste em abrir a boca ao máximo e projetar a língua para fora e para baixo (carea do Einstein), ao mesmo tempo que abrimos os olhos e voltamos os globos oculares para a testa.

Após essa série de exercícios, ficar em repouso por uns cinco minutos, respirando lentamente. Pode-se imaginar descansando diante de uma paisagem conhecida ou imaginária que seja bem repousante: um lago, o oceano, montanhas, etc. Antes de se levantar, fazer flexões e extensões dos membros, espreguiçando-se lentamente.



A morte e o morrer: aspectos psicodinâmicos

Roosevelt M. S. Cassorla

Quando o médico e a equipe de saúde defrontam-se com pacientes que vão morrer, são mobilizados por ideias, sentimentos e fantasias assustadores, que, na maioria das vezes, são negados. Há fortes indícios de que o medo da morte pode ser um motivador inconsciente da escolha profissional por parte de muitos médicos. Enfrentá-la pode estimular a criatividade de profissionais dedicados, que usam todos os recursos para recuperar a saúde de seus pacientes. No entanto, em alguns casos, o profissional pode chegar a perder o contato com a realidade, evitando perceber que a morte existe e faz parte da vida. Com isso, ele evita contato com sua impotência diante da realidade da morte e com o fato de que ele mesmo também é mortal. Essas defesas podem, entretanto, predispor a condutas onipotentes, vistas como heroicas, ainda que a razão mostre que nada mais há a ser feito para evitar a morte do paciente. Este capítulo aborda como reagimos, sob um ponto de vista da teoria psicodinâmica, diante da morte e do morrer.

Os conflitos pessoais, a “fobia” diante da morte e o morrer e sua contrapartida contrafóbica articulam-se com fatores sociais e culturais que têm tornado a morte algo feio, inoportuno, que deve ser escondida. Nas últimas décadas, o homem foi perdendo o direito sobre sua própria morte, que passou a ser controlada por profissionais específicos, entre eles os de saúde. A morte não só foi medicalizada como também vem sendo maquiada por especialistas cuja função é padronizar rituais de luto, sem envolvimento familiar, para que a morte e o morto incomodem o menos possível. Assim, se antes o moribundo podia morrer em sua casa, cercado de sua família e entes queridos, muitas vezes, reconciliando-se com eles e consigo mesmo, agora, ele não tem mais o direito de escolher, opinar ou mesmo saber exatamente o que está ocorrendo.

Essa tanatocracia tem sido questionada nos últimos anos, e a autora pioneira, que abriu espaço para o que hoje chamamos tanatologia, foi Elisabeth Kübler-Ross, uma psiquiatra suíço-americana, cuja rica experiência resultou em um texto clássico, *Sobre a morte e o morrer*.¹ Em seu último livro,² mostra-nos como experiências de sua vida a levaram a descobertas que vêm repercutindo na atenção aos pacientes que vão morrer. O desenvolvimento de suas ideias, em nosso meio, se encontra em Kóvacs³ e Santos.⁴

A desumanização do atendimento, a “coisificação” do paciente e a impossibilidade de se expressar como ser humano, em seus desejos e suas expectativas, não apenas aumentam seu sofrimento emocional como também repercutem nos tratamentos médicos em geral. Kübler-Ross descobriu que os pacientes que iam morrer eram ainda mais desconsiderados e abandonados. Observou também que esses pacientes, frequentemente, desejavam viver seus últimos dias em contato com pessoas queridas, em ambiente conhecido, e que essas mortes lhe pareciam muito mais tranquilas que aquelas observadas no isolamento dos hospitais e das UTIs. Entrevistando-os, surpreendeu-se com a quantidade de informações sobre seus sentimentos relacionados à morte e com o sofrimento adicional resultante do tratamento dispensado pela equipe de saúde e pela instituição.^{1,2}

No início de suas investigações, como psiquiatra em um hospital geral, Kübler-Ross necessitava de pacientes de outras clínicas para entrevistar. Os médicos, de forma geral, achavam-na estranha por interessar-se por esse assunto “mórbido” e negavam-se a permitir as entrevistas. Seus pretextos eram os mais variados: desde que os pacientes não gostariam de falar sobre sua doença, menos ainda sobre a morte, até a possível violência a que seriam submetidos. Além disso, existiam médicos que se recusavam a acreditar que seus pacientes poderiam morrer, e, em seu livro autobiográfico, Kübler-Ross² descreve como um conceituado cancerologista negava, de forma psicótica, que seus pacientes morreriam. A autora descobriu táticas carinhosas para mostrar ao médico como ele evitava entrar em contato com seu desespero e sua impotência, e ele ficou agradecido. Esse fato nos revela que o profissional de saúde mental, muitas vezes, precisa ser suficientemente criativo para encontrar táticas que permitam enfrentar situações aparentemente inabordáveis com colegas, pacientes e familiares.

Por meio da observação e do estudo de centenas de entrevistas, Kübler-Ross² constatou a existência de padrões de fantasias, comportamentos, ansiedades e defesas diante da morte. Em sua descrição, agrupou-os em cinco estágios pelos quais os pacientes passam, desde o momento em que se firma seu mau prognóstico (Quadro 27.1):

QUADRO 27.1

Estágios de Kübler-Ross^{1,2} e atitudes do médico e da equipe de saúde

Negação

Acolher e buscar compreender. Não romper as defesas. A atitude empática do médico permite introjeção de confiança e recursos para lidar com a realidade.

Raiva

Compreender e mostrar, quando possível, que a raiva é defesa contra a impotência, o desespero e a desesperança. Atitude firme não mostrando medo ou fraqueza. Nunca retaliar, atacando o paciente.

Negociação

Nunca desqualificar o paciente por suas fantasias ou escolhas nas barganhas. Aceitar negociações na relação profissional de saúde-paciente se elas forem razoáveis.

Depressão

Acompanhar o sofrimento do paciente empaticamente. Evitar apoios ou conselhos maníacos (“não é nada”; “logo vai passar”). Identificar variações entre depressão persecutória (em que predominará raiva projetada ou autodestrutiva) e depressão elaborativa (que demanda solidariedade e tempo).

Aceitação

Nunca abandonar o paciente. Observar e acompanhar regressões para estágios anteriores.

1. negação
2. raiva
3. negociação
4. depressão
5. aceitação

Em vários casos, a sequência pode não ser exatamente essa. Os estágios podem se mesclar, e alguns pacientes podem não passar por um ou outro, e, por vezes, ocorrem regressões a etapas anteriores. Verificou-se, também, que pacientes que não apresentam necessariamente risco de morte imediato, como os crônicos ou que perderam órgãos ou funções, podem também passar por esses estágios. Além disso, há uma semelhança com os mecanismos que utilizamos diante de qualquer perda, que pode ser considerada o prenúncio da necessidade de trabalhar o luto

envolvido. Além disso, essas etapas também ocorrem com os familiares do paciente. A isso acrescentamos que acontecem também com os médicos e demais membros das equipes de saúde. Nessas últimas situações, o papel do profissional especializado em saúde mental será ainda mais necessário e importante, assessorando a equipe assistencial original.

OS ESTÁGIOS DE KÜBLER-ROSS

Negação

Quando o paciente recebe a notícia sobre sua doença ou seu prognóstico, esse costuma ser o primeiro mecanismo emocional utilizado. Genericamente, podemos dizer que a negação é uma defesa psíquica que implica recusar-se a entrar em contato com um fato que promove turbulência e sofrimento emocional. Esse fato passa a ser tratado como não existente. Evidentemente, essa defesa não somente é perfeitamente compreensível como também necessária, por vezes impedindo uma desestruturação mental. Com isso, o mundo interno parece “ganhar tempo” para absorver o impacto e utilizar defesas mais adequadas.

Na verdade, o termo “negação” implica um conjunto de mecanismos mentais, muitos podendo ser inferidos pelo profissional de saúde mental e conhecidos em detalhes por meio da psicanálise. Sabemos que as ansiedades arcaicas, do início da vida, envolvem terrores de aniquilamento. A forma como se constituirá o mundo interno de qualquer ser humano dependerá, em grande parte, da forma como o bebezinho e seu ambiente foram capazes de lidar com essas ameaças internas.

Pacientes que utilizam predominantemente mecanismos de cisão e identificação projetiva (comuns na posição esquizoparanoide) são os que se sentem mais ameaçados por esses terrores e tendem a negações tão intensas e duradouras que lembram o psicótico, correndo o risco de se desagregarem se os mecanismos defensivos não forem suficientes.^[NT] Outros pacientes, em que predominam vivências gratificantes em suas vidas (objetos bons internalizados), podem se sentir menos aterrorizados; portanto, os mecanismos envolvidos na negação são mais evoluídos (funcionamento da posição depressiva). Nessas situações, é possível um maior contato com a realidade e o uso de outros mecanismos que não a negação. Essa dinâmica emocional permite uma passagem menos sofrida para as etapas seguintes, rumo à elaboração, como a depressão e a aceitação.⁵

Raiva

Quando o paciente não pode mais negar, ou o impacto sentido foi tão grande que a negação se tornou impossível, ele se sente tomado pelo ódio e pode demonstrar seu inconformismo por meio de condutas violentas. Mostra-se agressivo e desafiador, atacando a tudo e a todos. Pode recusar-se a efetuar procedimentos médicos e tornar-se um problema para a família e para a equipe de saúde. As questões básicas que o perseguem são como as seguintes: “Por que eu?”, “Por que agora?”, e as brigas consigo mesmo, com Deus e com quem estiver próximo serão o resultado da tomada de consciência, inconformada, da realidade.

Em termos psicanalíticos, observamos que o paciente está utilizando mecanismos primitivos, expelindo seus conteúdos aterrorizantes, “enfiando-os” nas pessoas próximas (identificação projetiva), que passam a ser vivenciadas como responsáveis pelo sofrimento, merecendo ser punidas por isso.⁵ A fantasia inconsciente é resultado da necessidade de encontrar responsáveis

pelos terrores de aniquilamento insuportáveis, internos, que, projetados, agora lhe parecem vir de “fora”. O mecanismo é similar ao que efetua um paciente psicótico quando, ao expelir seus conteúdos internos, os alucina e delira, no que chamamos “restituição psicótica”. Nessas fases, seu terror inominável passa a ter uma “explicação”, fruto de algo “externo”, acalmando o desespero ligado ao risco terrível da desestruturação psicótica.

A intensidade e a qualidade desses mecanismos vão decorrer também das características individuais do paciente. Aqueles que já usavam mais mecanismos projetivos, “paranoides”, tenderão a usá-los com mais vigor do que outros pacientes, que vivenciaram melhor suas experiências vitais. Os primeiros terão mais dificuldades em ultrapassar esse estágio, e alguns poderão ter uma morte penosa, cheios de rancor e ódio, não podendo reconciliar-se consigo mesmos e com os demais. A equipe assistencial, evidentemente, será mais exigida nesses casos e comumente necessitará da ajuda do profissional de saúde mental.

Não nos esqueçamos de que os vários estágios se interpenetram e alternam, nada impedindo que pacientes passem por momentos de raiva, em seguida, de negação, e depois voltem a esse estágio, em estado de calma aparente. Outros parecerão fenomenologicamente deprimidos, voltando o ódio para dentro de si mesmos, no que veremos adiante como depressão persecutória.

Negociação

Nesse estágio, o paciente aceita a realidade, mas tenta efetuar barganhas, “acordos”, que lhe possibilitem manter uma visão não totalmente realística dos fatos, ou negocia para poder aproveitar melhor o tempo que lhe resta. É a fase de promessas efetuadas a Deus ou outros entes sobrenaturais, de mudanças de vida, de desejos de adiamento da morte até que determinados fatos ocorram, etc. Nessa etapa, mesclam-se vários mecanismos, como projeção de aspectos aterrorizantes, idealização, negação maníaca, revisão e tentativas de anulação de culpas, tendências à reparação, etc. Certamente, somente é possível em pessoas que já estão alcançando algum contato razoável com a realidade somado a certa vitalidade. Pacientes com funcionamento mental predominantemente persecutório terão mais dificuldade em atingir esse estágio.

A observação clínica mostra-nos, com frequência, que, nessa etapa, ocorrem processos criativos, como pessoas usando o tempo para reavaliar suas vidas, preparando-se para um processo de reconciliação com o mundo e consigo mesmas, esboçando mecanismos de reparação, e até conseguindo o tempo necessário para realizarem algo que muito desejariam, como ver o neto que vai nascer, acabar de escrever um livro, arrumar seus negócios, etc. Isso nos mostra que existe certo controle sobre o momento da morte quando existe força vital para tal. ^[NT]

Depressão

Nesse estágio, a pessoa estará elaborando lutos. O luto pelos entes queridos, pelas vivências agradáveis, pelas oportunidades não aproveitadas, por situações e pessoas a que se apegou, pela própria vida, etc. O paciente apresenta-se retraído, triste, sofrendo intensamente, e evita o contato

com pessoas que não respeitem seu momento. Entretanto, necessita muito de companhia, de alguém sensível que o acompanhe, mas sem invadi-lo ou perturbá-lo.

Devemos diferenciar a depressão persecutória, mais própria do estágio de raiva, em que o paciente está rancoroso e agressivamente triste, da depressão elaborativa, em que ele está tentando trabalhar as perdas e os ganhos da vida, rumo à aceitação mais tranquila do inevitável. Quadros mistos evidentemente são encontrados, e a equipe assistencial deve agir de forma diferente, levando em conta os mecanismos de defesa predominantes.

Aceitação

A esse estágio chegam pacientes que superaram os anteriores, e a chance de que isso ocorra é maior se tiveram ajuda durante todo o processo. Tendo-se realizada a despedida das experiências vividas e dos entes queridos, pode manifestar-se grande paz e tranquilidade. O paciente parece desligado, dorme bastante, como que repousando de um sofrido processo, possivelmente preparando-se para outro. É essa tranquilidade que diferencia a fase de aceitação da anterior, a depressão, em que se percebe que ainda existe sofrimento considerável.

Nem todos os pacientes atingirão essa última fase, ou mesmo algumas das anteriores. Será o apoio emocional que lhes permitirá chegar a ela, caso não tenham recursos próprios. Esse apoio somente poderá ocorrer, conforme vimos, se a instituição aceitar que o paciente possa participar de sua própria morte, escolhendo sua forma e seu lugar. Não cabe, portanto, deixar morrer um paciente em um hospital se ele prefere sua residência e o contato com sua família, ou a utilização de recursos heroicos, que o médico sabe que apenas prolongarão a vida por algumas horas ou dias, sem que o paciente seja respeitado em seus desejos.

Um exemplo desse tipo de situação encontra-se na vinheta de caso a seguir:

Uma profissional da saúde consultou um ginecologista, que lhe solicitou um exame anatomopatológico de tecido uterino. O médico sabia que as chances de malignidade eram grandes e estava bastante preocupado sobre como lidar com o assunto quando o resultado viesse. No entanto, surpreendeu-se quando, ao receber a paciente, ela entrou mostrando-lhe o exame, já aberto, com um sorriso nos lábios e dizendo: “Graças a Deus, são células benignas”. O ginecologista, aliviado, mas desconfiado, foi ler o exame, que, na verdade, indicava malignidade, sem sombra de dúvida. Ficou confuso e já ia refutar, quando percebeu que a paciente, talvez, não estivesse em condições de ouvir a verdade. Ficou em dúvida se essa percepção decorria de seu medo (do ginecologista) em lidar com a má notícia ou da percepção (contratransferencial) do estado emocional da paciente. Optou pela segunda alternativa, sabendo que teria tempo para corrigir-se caso sua hipótese estivesse errada. Apenas disse: “Bem, tendo em vista o exame, vamos ter que operar”. A paciente concordou imediatamente. O médico falou da cirurgia, da necessidade de examinar todos os órgãos e dos tratamentos subsequentes para o câncer, naturalmente, sem usar aquela palavra, ao que a paciente aquiesceu.

Logo que se iniciou o tratamento quimioterápico, tendo sido encontradas várias metástases, a paciente não conseguiu mais manter a negação e solicitou, desesperada, “qualquer tipo de ajuda”. Foi encaminhada para um profissional de saúde mental, especializado nessa área. Ao consultá-lo, chegou aterrorizada, com risco de se desagregar e com ideias suicidas. Nesse momento, ainda mais devido a sua profissão, tinha consciência clara do prognóstico, ainda que seu estado geral se mantivesse razoável. Contudo, logo passou a atacar violentamente o psicoterapeuta e, após algumas sessões, encerrou o tratamento. Substituiu-o por ajudas “alternativas” e religiosas, tornando-se mística quase fanática, o que lhe possibilitou passar por uma fase de aparente esperança.

Ao mesmo tempo, sua família desesperou-se ao vê-la tão perturbada e a levou contra sua vontade a um psiquiatra, que a acompanhou prescrevendo medicamentos, chegando a altas doses de antidepressivos e à utilização de antipsicóticos. No entanto, seu estado emocional piorava cada vez mais, percebendo-se um aumento preocupante na ideação suicida, o que fez o psiquiatra propor uma internação. Nesse instante, surpreendentemente, a paciente pediu para voltar a ver o psicoterapeuta, o mesmo que havia abandonado anteriormente. O processo terapêutico foi possível, criando-se um vínculo de confiança, e, graças a ele, a paciente pôde revisar sua vida, reconciliando-se com seus objetos internos e externos. Conforme seu estado físico foi se tornando cada vez mais debilitado, foram trabalhados seus aspectos emocionais, já em um contexto predominantemente de depressão elaborativa. O mesmo ocorreu com sua família, que também era ajudada pelo psicoterapeuta.

Esse conjunto de elementos, somado à generalização das metástases, permitiu que a paciente e sua família, meses depois, percebessem que o momento da morte estava próximo. Contudo, uma intercorrência a levou a ser hospitalizada. Era óbvio que a paciente iria morrer, quando ela conseguiu dar a entender que preferiria morrer em casa. No entanto, a alta somente foi concedida “a pedido”, e os médicos se isentaram de qualquer “consequência”. A paciente faleceu dignamente, cercada e acarinhada por seus filhos e familiares, com quem conseguiu, a muito custo, ter conversas individuais, por palavras e gestos, despedindo-se, desculpando-se, aconselhando e, surpreendentemente, conseguindo ser bastante clara para ser compreendida. O psicoterapeuta também recebeu a mesma atenção, com demonstrações de gratidão. Tudo isso ocorreu de forma tranquila, tendo a tristeza de todos sido vivida lado a lado com a aceitação de que a despedida, por mais sofrida que fosse, fazia parte da vida e estava acontecendo da melhor forma possível.

Evidentemente, nem todos os pacientes têm essa possibilidade de tratamento, e será o profissional de saúde mental que, muitas vezes, dará a retaguarda à equipe assistencial e aos familiares para que exerçam o papel terapêutico. Qualquer profissional da saúde, ou mesmo leigos, pode e deve agir psicoterapeuticamente, dando apoio ao paciente e compreendendo-o, o que discutiremos em mais detalhes adiante. Religiosos e voluntários podem ser também de grande ajuda, mas, por vezes, verifica-se que muitos não têm condições de ir além das orações e textos burocráticos, tentando escapar o mais rapidamente possível de um contato mais profundo.

No caso descrito, verificamos que, após a fase de negação, veio o terror da desagregação, a identificação projetiva desse terror no psicoterapeuta (de forma tão violenta que ele foi abandonado raivosamente) e nas pessoas em geral, a negociação com tratamentos alternativos, com o uso de defesas maníacas, a culpa e as tentativas de reparação da família, o trabalho inconsciente que a mente da paciente efetuou, permitindo-lhe a retomada da ajuda psicoterápica, a depressão elaborativa e a reconciliação e reparação ocorrendo também no núcleo familiar e, por fim, a morte digna e tranquila. Aparece também o desespero da equipe hospitalar, que se sente ameaçada com a solicitação de alta, talvez por culpa e medo de conscientizar-se de sua impotência (que pode ser racionalizada por risco de processos judiciais) e da pouca resposta a tratamentos estritamente biológicos.

O PROFISSIONAL DE SAÚDE MENTAL DIANTE DO MORRER

Em outros capítulos deste livro e em vários trabalhos,^{7,8} são abordadas as várias formas de interconsulta e de participação do profissional de saúde mental no hospital geral, assim como algumas de suas características necessárias.

Com grande frequência, a solicitação de auxílio do profissional de saúde mental decorre de dificuldades no lidar com o paciente, no sentido da relação humana. Por vezes, podemos separar essas dificuldades em relação a sua origem, predominando os problemas emocionais em uma das seguintes personagens: no paciente; na família; no médico e na equipe assistencial; na instituição, em sua subcultura. No entanto, a observação minuciosa constatará que, quase sempre, todos os participantes do processo estão envolvidos, ainda que em graus diferentes. E isso não é difícil de compreender se nos lembrarmos de que os sentimentos e emoções são “contagiosos”, isto é, atingem as pessoas envolvidas por meio de mecanismos como a identificação projetiva e introjetiva.

As defesas contra esse sofrimento emocional também serão mobilizadas, e elas serão diferentes, dependendo das características individuais de cada ator envolvido ou de características subculturais dos agrupamentos de pessoas exigidas. Por esse motivo, porque todos estão impregnados da “insalubridade” que provoca sofrimento e possíveis crises, é que o profissional de saúde mental deve agir nas relações paciente-profissionais-família, ajudando a constituí-las ou refazê-las de formas mais adequadas.

Lidando com o paciente

Um vínculo emocional é constituído a partir do que chamamos de “conversa”. Conversar, nesse contexto, significa oferecer-se como ser humano, ouvinte e disposto a receber não somente palavras, mas também sentimentos. Assim, a conversa pode ser verbal ou não verbal.

Os psicanalistas utilizam um modelo chamado “continente”, que implica a presença de um ser humano que vai se deixar invadir pelos sentimentos e emoções que não podem ser pensados pelo paciente, geralmente de conteúdo aterrorizante. Esse ser humano “digerirá” esses conteúdos impensáveis e os devolverá, adequadamente, “pensados”. O modelo decorre da relação mãe-bebê: este último, mesmo não falante, externalizará seu desespero por meio do choro ou outros sinais. A mãe “continente” acolherá esse desespero, sem desesperar-se tanto, e devolverá ao bebê proteção e carinho por meio de atos ou palavras. Aos poucos, essa mãe “continente” é introjetada (passa a fazer parte do mundo interno do bebê), e a criança passa a necessitar menos da mãe concreta, e esta passa a ser substituída por “objetos internos” continentes.

No entanto, em situações-limite, como as que tratamos neste capítulo, essas necessidades serão revividas e com mais intensidade se as experiências de “continência” arcaicas não tiverem sido satisfatórias. Mas, ainda que o tenham sido, todo ser humano na iminência da morte necessitará de outro ser humano que funcione como “continente”.

Ser “continente” implica ouvir, ouvir mesmo o silêncio. E, aqui, entra em jogo a intuição empática, uma característica desenvolvida pelo clínico a partir de sua experiência de contato

intenso com seres humanos. Por intermédio dela, o médico (ou outro profissional) percebe se deve ou não falar, o que e quando. A intuição empática decorre de uma identificação profunda com o outro, com o sofrimento do outro, e ela corresponde ao que o médico foi capaz de absorver do seu semelhante em sofrimento. Intuição empática faz parte do arcabouço emocional de qualquer ser humano, e ela se desenvolve com a experiência, com o convívio com colegas mais experientes, com treinamentos específicos, como os grupos Balint⁹ e com a análise pessoal. Pelo fato de seu estudo ser efetuado por áreas não biológicas, os médicos têm certa desconfiança em relação a ela, ainda que todos saibamos que ela é utilizada diuturnamente pelos clínicos, mesmo sem que estes o percebam. Médicos famosos por seu “olho clínico” e/ou por sua boa relação emocional com o paciente se valem dessa característica de forma não consciente.

É errado pensar que conversar com um paciente “fora de possibilidades terapêuticas”^[NT] envolve sempre falar sobre a morte. Quem dirige o conteúdo da entrevista será sempre o doente, e é ele que levantará os problemas da forma e no momento que desejar ou se sentir capaz. O profissional ficará junto, ouvindo e deixando-se penetrar pelas palavras e pelos sentimentos, ou somente por estes, se não existirem palavras. Sentar-se junto a um paciente deprimido, que não fala, e aceitar que pegar na sua mão pode ser altamente terapêutico, é algo que todo profissional logo percebe. O doente, ainda que silencioso, mostra sua gratidão e sente a falta daquele interlocutor que o respeita, inclusive em seu silêncio.

Crianças, mais espontâneas, ensinam muito ao profissional, pois suas defesas costumam ser menos rígidas, e têm menos “pendências” para resolver.^[NT] Assim, se encontrarem um adulto continente, expressarão de forma mais clara seus sentimentos pela fala, atos, desenhos ou jogos.

O conhecimento das etapas pelas quais o paciente está passando ajuda o profissional em sua atitude receptiva. Há que se respeitar a negação, mas temos que “estar junto” para que o paciente, se tiver condições, permita-se o risco de abandonar essa defesa, sabendo que terá alguém próximo que o auxiliará a defrontar-se com a realidade, acolhendo seu sofrimento e tornando-o mais suportável. A experiência nos mostra que a obsessão do médico em “falar a verdade”, friamente (o que ocorre em outras culturas), sem que tenhamos avaliado as características emocionais do doente, as ansiedades e as defesas predominantes naquele momento, pode ser prejudicial.

Sabemos, contudo, que sempre o paciente intui ou sabe da verdade: nossa função será identificar os mecanismos diante dos quais se protege dela ou as formas como dela vai se aproximando. Quando o paciente efetua um vínculo com o profissional (ou com o parente, o leigo, etc.), dará sinais de que quer conversar sobre a verdade e de que forma deseja fazer isso. Basicamente, o paciente deverá ser informado daquilo que quer saber e no momento em que quiser. Será ele próprio quem nos dará os sinais para isso. No entanto, ainda que omitamos aspectos enquanto não conhecermos, em detalhes, o funcionamento mental do paciente, nunca devemos mentir ou enganar. O doente o perceberá, consciente ou inconscientemente, e a relação profissional de saúde-paciente estará comprometida talvez para sempre.

Assim, à velha questão que os médicos se fazem “Devo dizer a verdade ou não?”, a resposta é simples. Sim, é preciso dizer a verdade, mas da forma e em momentos adequados, e estes serão sinalizados pelo próprio paciente. Não é raro que o paciente perceba a ansiedade de seu médico,

que não consegue lidar com a verdade, e carinhosamente o poupe, em uma espécie de conluio, em que o paciente protege o médico.

O mesmo pode ocorrer em relação a parentes, e não é raro que nos defrontemos com pacientes que sabiam sobre a proximidade de sua morte, mas solicitam à equipe de saúde que não contem aos seus parentes, porque “eles não iriam suportar”. Paradoxalmente, os familiares podem ter efetuado a mesma solicitação – que não se contasse ao paciente que ele ia morrer. Esse conluio, em que todos sabem de tudo e fingem que não sabem, leva a sofrimentos desnecessários, que se diluem quando todos se defrontam com a verdade. Nesse momento, há tempo para conversas, avaliações e reavaliações, despedidas, lutos bem elaborados e mortes dignas.^{3,10-13}

Enfim, como profissionais da saúde, familiares e pacientes, cultural e emocionalmente, têm grande dificuldade em lidar com a realidade da finitude humana, corre-se o risco de que percam a possibilidade de perceber os sinais de sua proximidade. No entanto, se esses sinais são identificados, aceitos, discutidos, a possibilidade de que o processo de morrer seja algo elaborativo, criativo, digno, tem grandes chances de ocorrer. E será o profissional de saúde mental ou o tanatologista o indivíduo mais adequado para captar e trabalhar esses sinais.

Lidando com a equipe assistencial

O médico assistente e/ou outros membros da equipe podem estar sofrendo tanto com seu “fracasso” em impedir uma morte que se afastam do paciente, abandonando-o. Os doentes percebem isso imediatamente e, além de se sentirem rejeitados, sofrem pela frustração que causam aos demais. Por vezes, essa mesma equipe pode efetuar intervenções desnecessárias ou que causam grande sofrimento, não avaliando conscienciosamente sua utilidade, em um desespero de evitar uma morte que sabe que é inevitável.

Racionalizações do tipo “foi feito tudo o que a medicina permite” escondem a dificuldade em lidar com as limitações e a perda da onipotência. Evidentemente, sempre é preciso usar todos os procedimentos médicos necessários, mas há que se perguntar se seu resultado será benéfico em termos de melhor qualidade de vida ou resultado de um desespero que deteriorará as condições de morte, impedindo uma morte digna. Portanto, deve evitar-se a obstinação terapêutica. Outras racionalizações são efetuadas utilizando-se argumentos jurídicos. O profissional deve também levar em conta os fatores econômicos, que tanto impedem a realização de procedimentos médicos como os estimulam desnecessariamente.

Evidentemente, ao conversar com um paciente sobre o que ele deseja saber, há que fazê-lo de uma forma tal que ele ouça aquilo que já sabe, ou intui, de forma carinhosa, oferecendo-se como ser humano que vai acompanhá-lo na jornada com que se defrontará. Esse acompanhamento implica continuar tratando o paciente, eliminando-lhe os incômodos físicos (que, para o observador, podem não ser tão terríveis como o são para o doente). Em especial, a dor (e sabemos que o Brasil é um dos países em que menos se usam analgésicos potentes) e pequenos cuidados que evitem sofrimento desnecessário (como uma incomodativa agulha de soro, a secura dos lábios, a luminosidade, a posição do corpo, etc.) não podem ser negligenciados. No entanto,

tão importante quanto isso é estar presente, como ser humano, disposto a servir de continente para as ansiedades e fantasias do paciente, ditas ou silenciadas.

Nos últimos anos, vem se enfatizando a necessidade do que se chama “cuidados paliativos”, que implicam cuidado total e ativo de pacientes cuja enfermidade não mais responde aos tratamentos curativos, e em que a prioridade é o controle da dor e a abordagem de aspectos psicológicos, sociais e espirituais. Os cuidados paliativos implicam não apressar nem adiantar a morte, oferecem um sistema de ajuda e apoio para viver tão ativamente quanto possível até a morte, além de ajudarem a família a lidar com seus conflitos, perdas e lutos. Para tal, é necessária a intervenção diretiva de equipe multidisciplinar preparada, na qual o profissional de saúde mental tem um papel importante.^{4,14,15}

Problemas éticos e legais ocorrem em relação à eutanásia, isto é, a morte provocada com o intuito de evitar sofrimento. Trata-se de situações complexas cujo ordenamento jurídico vem sendo discutido em vários outros países, as quais são abordadas no Capítulo 28.

Lidando com os familiares

Os familiares do paciente com frequência também estão despreparados cultural e emocionalmente para defrontar-se com a morte e o morrer de uma pessoa próxima. Comumente esperavam que o médico e a instituição hospitalar curassem seu parente, e uma possível idealização pode desabar, com consequências as mais variadas. Uma delas, cada vez mais comum, é utilizar a projeção de sua impotência, seu desespero e sua culpa nos profissionais da saúde, que são, assim, responsabilizados e agredidos.

Muitos processos judiciais contra médicos e hospitais têm essa origem. Entretanto, é preciso lembrar que, por vezes, o próprio profissional estimulou a idealização, negando-se a abordar de forma verdadeira o prognóstico e as limitações da medicina. O médico e qualquer profissional da equipe (e também o interconsultor da área de saúde mental) devem estar conscientes da seguinte armadilha: o paciente ou um familiar o idealiza (“O senhor é o único médico que poderá curá-lo” ou “É Deus no céu, e o senhor, na terra”). Está aberta a possibilidade para que o profissional, narcisicamente, acredite-se um Deus e perca o contato com a realidade. Quando se descobre que ele não era onipotente, que era apenas um médico, um ser humano com todas as limitações a ele inerentes, transforma-se em um ser malvado, diabólico, que será desprezado e atacado. Nessas ocasiões, o médico se deprime persecutoriamente com o “fracasso” ou, na melhor das hipóteses, toma consciência de suas limitações. Contudo, necessitará da ajuda de colegas, da própria equipe ou da área de saúde mental, que poderão catalisar o trabalho mental de elaboração de sua onipotência abalada com a perda do paciente e com os ataques externos e internos amedrontadores, desesperantes e que geram culpa.

Como vimos, o familiar passa pelos mesmos estágios que Kübler-Ross^{1,2} descreveu para o paciente. A negação poderá impedi-lo de tomar as providências necessárias, levando-o posteriormente a sentimentos de culpa. A raiva pode ser projetada na equipe de saúde, como vimos, ou no próprio paciente, que é maltratado como se ele próprio fosse o responsável por sua doença e sua morte. Não é raro que a família se cinda, desagregue, ocorrendo inimizades e

acusações (às vezes, já existentes) entre seus membros, com frequência envolvendo o paciente e a equipe médica nos conflitos. Nesses momentos, o profissional de saúde mental e a equipe de saúde como um todo podem e devem trabalhar com a família, poupando o paciente e facilitando uma reconciliação com este e entre os vários membros, em crise terrível, condição básica para uma elaboração adequada do luto.

Estamos lidando, nas situações já descritas, basicamente com sentimentos de culpa, que invadem todos os participantes do drama, ou são expelidos e projetados em outros. Porém, as culpas podem decorrer de fatores anteriores: de fantasias conscientes ou inconscientes, relacionadas à ambivalência entre amor e ódio. Em outras palavras, todos sentimos esses dois sentimentos em relação a nossos familiares, e, caso não saibamos lidar adequadamente com eles, sobretudo se o ódio se descola do amor, o sentimento de culpa será predominante. Essa culpa poderá ser persecutória (com terrores de retaliação e identificação com o doente e o morto, levando a lutos que causam efeitos somáticos e mortíferos) ou reparadora, rumo à reavaliação, em que se retoma o lado amoroso cindido, com a reconciliação e o luto elaborativo. Novamente, agora, o profissional de saúde mental, que deve identificar esses mecanismos, poderá ser de grande ajuda.

Outras reações do familiar implicam desprezo manifesto e abandono do paciente, desespero que pode levar a atos impensados, incompreensão das necessidades do doente, etc. Há que se identificar as motivações dessas condutas, e, para isso, os parentes devem ter um espaço acolhedor, em que possam externar seus sentimentos, espaço esse que terá de ser fornecido pela equipe assistencial ou/e pelo profissional de saúde mental. Esse será o momento ideal para que se possa, quando possível, efetuar uma reaproximação dos familiares, consigo mesmos e com os demais, assim como poderá haver um trabalho rumo à resolução de “pendências” entre os membros da família e com o paciente. Com isso, evitaremos lutos patológicos, que incluem identificações com o morto, quadros melancólicos, somatizações e mortes, suicídios e autopunições inconscientes, que poderão perdurar pelo resto da vida, atingindo, inclusive, próximas gerações.

Lidando com a instituição

Como vimos, a instituição hospitalar não está preparada para cuidar de pacientes que estão morrendo. Frequentemente, o paciente é abandonado pela equipe assistencial, ou, em casos que envolvem culpas, onipotência da equipe ou ganhos financeiros, o paciente pode ter sua vida prolongada desnecessariamente, a despeito de suas próprias solicitações sutis ou manifestas. O ideal é que a instituição permita que o paciente possa decidir, na medida do possível, sobre sua vida e forma de morrer. Em geral, eles desejam estar próximos a seus entes queridos, em um ambiente conhecido.

Evidentemente, os familiares têm também que ter condições emocionais e materiais para tal. Existem famílias que preferem (ou precisam) “fugir da morte”, abandonando o paciente. Famílias preparadas pela equipe assistencial a auxiliarão muito, durante o processo de morrer, tanto na residência do doente quanto no hospital. A desumanização das instituições hospitalares

as leva a uma rigidez totalmente desnecessária, impedindo visitas e dificultando qualquer contato humano mais profundo, não somente necessário, mas indispensável.

Está claro que não cabe o recurso de UTIs para pacientes sem nenhuma chance de sobrevivência, morrendo isolados, intubados e dopados, não podendo realizar as despedidas necessárias. Existe, inclusive, um movimento mundial para humanizar as próprias UTIs. Tudo isso tem de ser questionado, usando as táticas adequadas a cada situação, pelo profissional de saúde mental, associado a todos os profissionais, da saúde ou não, sensíveis a esses fatos.

Em países desenvolvidos, cada vez mais se criam instituições (que mantêm seu nome original, do inglês, *hospice*) onde pacientes podem passar suas fases finais atendidos por equipes especializadas, em um ambiente confortável e de assistência médica e psicossocial, com participação de familiares e amigos. Diferentemente do que poderia parecer, não se trata de instituições deprimentes, mas nas quais existe uma paz e tranquilidade que possibilitam a morte digna e a elaboração adequada dos lutos.

Lidando com a sociedade

Não é nada fácil mudar padrões culturais e subculturais, como aqueles que impregnam a morte e o morrer, em nossa sociedade. As pesquisas, cada vez mais numerosas, mostram essa necessidade, e novamente serão os profissionais da saúde aqueles que, diuturna e pacientemente, terão que provar, pelos fatos, que todas as considerações declinadas devem ser levadas em conta. Trabalhar conscienciosamente e nunca se negar a discutir, em qualquer oportunidade, aspectos sobre a desumanização da medicina, o poder da indústria farmacêutica e de aparelhos médicos, o ensino médico em que se nega o emocional. Essa será sua tarefa política – constante – como técnico e cidadão, porque ele, o profissional da saúde, é quem tem os elementos científicos necessários para isso.

Por vezes, profissionais ou leigos de outras áreas podem auxiliar, como religiosos esclarecidos, advogados, educadores, grupos de familiares, sociedades que agrupam determinados tipos de doentes, etc. No entanto, quase sempre, a liderança caberá a quem lida diretamente com o doente: o profissional da saúde.

Características pessoais do profissional de saúde mental

Terminaremos este capítulo alertando sobre as características necessárias para que o agente de saúde mental trabalhe de forma adequada. O profissional que lida com a morte e o morrer, com pacientes, familiares, equipes de saúde, instituição e sociedade, como psiquiatra de ligação, como membro da equipe ou como interconsultor, deve ter as características comuns a todo profissional da saúde: preparo técnico, amor à verdade, capacidade de ter empatia pelo sofrimento alheio, condições para relacionar-se com outros seres humanos, atitudes psicoterápicas, ética profissional, etc.

Além dessas características, são desejáveis outras, que podem ser desenvolvidas na experiência do dia a dia, no aprendizado com colegas mais experientes, em grupos de discussão

de casos (como os grupos Balint) e na análise individual.

1. **Aceitação da realidade da morte:** há que se conscientizar de que a morte é um fato da vida, natural, e que dela faz parte. Os terrores decorrem muito mais do desconhecido e da perda dos vínculos do que da morte em si, já que nada se sabe sobre ela.^{10,11}
2. **Aceitação das limitações humanas:** o profissional da saúde deve aceitar suas limitações, sem reagir a elas caindo em uma onipotência que pode beirar à mania psicótica, e não se melancolizando, sentindo-se culpado e impotente. As culpas pela não onipotência perseguem os profissionais que ainda não se deram conta da potência relativa de seus recursos, tanto da medicina como os pessoais. Humildade, sem perder a potência, e o uso máximo dela, mas sem cair na onipotência, resumiria esse dito.
3. **Capacidade de identificar e resolver conflitos complexos:** aqui entra a necessidade do profissional de saúde mental de desenvolver sua percepção dos mecanismos emocionais, geralmente confusionais, que envolvem todos os atores do drama que resultará em morte, perdas, lutos, raivas, culpas, punições e sofrimento. Muitos profissionais têm sensibilidade especial para isso, decorrente de suas próprias experiências pessoais. Mesmo estes, e também aqueles que têm mais dificuldades, terão que tomar consciência de seus próprios conflitos para que, ao não misturá-los com os dos demais, possam servir como agentes psicoterapêuticos.
4. **Ética:** o exercício indispensável dos preceitos éticos pelo tanatologista é mais complexo do que para os demais profissionais. Falar a verdade faz parte da ética, mas existem as nuances já discutidas relativas à forma e ao momento. E essa verdade não é só a do paciente, mas a dos familiares, dos colegas e da instituição. A omissão não é ética, mas o “furor” em dizer a verdade pode torná-la prejudicial. Lembremo-nos de que expor a verdade sem amor é crueldade.
5. **Cuidados pessoais:** o profissional que lida com a morte e o morrer, mais que os outros, trabalha em um ambiente psiquicamente insalubre. Ele estará constantemente sendo alvo de identificações projetivas e da introjeção de aspectos altamente perturbadores. Por vezes, necessidades imperiosas de reparação maníaca, culpas e necessidade de autopunição inconsciente fazem o profissional não se cuidar e entrar em uma rotina extenuante, sem descanso físico e emocional. Isso lhe acarretará, além de uma má qualidade de vida, maior vulnerabilidade a sofrimento físico, emocional e social. O profissional da saúde deve, portanto, estar sempre alerta, sabendo cuidar-se em relação a envolvimento exagerados, por vezes desnecessários, e questionar-se constantemente sobre os motivos que o levam a essa atividade e em que grau. Conhecer a si mesmo será indispensável se perceber que sua vida não é satisfatória, e isso poderá ser efetuado em terapias pessoais.

REFERÊNCIAS

1. Kübler-Ross E. Sobre a morte e o morrer. São Paulo: Martins Fontes; 1998.
2. Kübler-Ross E. A roda da vida: memórias do viver e do morrer. Rio de Janeiro: GMT; 1998.
3. Kovács MJ. Morte e existência humana. São Paulo: Guanabara-Koogan; 2008.
4. Santos FS, organizador. Cuidados paliativos: discutindo a vida, a morte e o morrer. São Paulo: Atheneu; 2009.
5. Klein M. As origens da transferência. Rio de Janeiro: Imago; 1991.
6. Hershey Jr RD. Rise in death rate after new year is tied to the will to see 2000 [Internet]. New York Times, jan. 2015 [capturado em 19 jan. 2017]. Disponível em: <http://www.nytimes.com/2000/01/15/nyregion/rise-in-death-rate-after-new-year-is-tied-to-the-will-to-see-2000.html>.
7. Cassorla RMS. Psiquiatria no hospital geral: reflexões e questionamentos. Rev ABPAPAL. 1996;18(1):1-8.
8. Cassorla RMS. O psiquiatra na equipe médica: retratos e caricaturas. Cadernos IPUB. 1997;6:45-58.
9. Cassorla RMS. Dificuldades no lidar com aspectos emocionais na prática médica: estudo com médicos no início de grupos Balint. Rev ABPAPAL. 1994;16(1):18-24.
10. Cassorla RMS. Da morte: estudos brasileiros. 2. ed. Campinas: Papirus; 1998.
11. Cassorla RMS. A negação e outras defesas contra a morte. In: Santos FS, organizador. Cuidados paliativos: discutindo a vida, a morte e o morrer. São Paulo: Atheneu; 2009. p. 59-76.
12. Kovács MJ. Morte e desenvolvimento humano. São Paulo: Casa do Psicólogo; 1992.
13. Tizón JL. Pérdida, pena, duelo. Barcelona: Paidós; 2008.
14. Rezende VL, organizadora. Reflexões sobre a vida e a morte: abordagem interdisciplinar do paciente terminal. Campinas: Unicamp; 2000.
15. Figueiredo MGMCA, Figueiredo MTA. Cuidados paliativos. In: Incontri D, Santos FS. A arte de morrer: visões plurais. São Paulo: Comenius; 2007. p. 196-206.

[suficientes] Para defender-se dos terrores de aniquilamento do início da vida, o bebê cinde o ego e os objetos e os projeta no objeto. Dessa forma, o objeto se torna perseguidor. Daí o nome esquizo (cisão) paranoide. Na posição depressiva, o ego está mais integrado, há visão binocular de que o mesmo objeto frustra e gratifica, e a percepção do mundo é mais realista. O termo “depressivo” indica contato com e aceitação da realidade. Não deve ser confundido com a patologia depressiva. A posição depressiva implica depressão elaborativa. Quando predominam mecanismos da posição esquizoparanoide, ocorre depressão persecutória ou melancólica.

[força vital] Notícia do *The New York Times* de 15/01/2000⁶ mostra, por meio de estatísticas de óbitos nos hospitais da cidade, que certamente muitos pacientes “adiaram” sua morte para o ano 2000 como que desejando entrar vivos no suposto novo século.

[possibilidades terapêuticas] Não existem “pacientes fora de possibilidades terapêuticas” se consideramos que a equipe de saúde estará, sempre, ajudando o paciente a lidar com sua doença e com a morte.

["pendências" para resolver] Chamamos de “pendências” as situações ou fantasias que não puderam ser trabalhadas adequadamente no passado. Envolvem frustrações e mágoas, lutos mal elaborados, raiva ressentida, segredos que não puderam ser contados, etc.



Aspectos éticos e legais

Neury José Botega
Luís Fernando Tófoli

No hospital geral, o psiquiatra geralmente é chamado para atuar em situações de crise. Trabalha em condições distintas das existentes em consultórios ou instituições psiquiátricas. Terá de ser mais flexível, baseando suas decisões em poucas informações, em um curto espaço de tempo, fora de um ambiente psiquiátrico, contando com uma equipe assistencial sobre a qual tem pouco controle, além de atuar em situações condicionadas por uma combinação de fatores orgânicos, sociais e psicodinâmicos. Essas características de seu trabalho podem torná-lo mais suscetível a vários dilemas éticos e situações que trazem repercussões jurídicas. Em relação a estas, vale lembrar o conselho frequentemente ouvido de especialistas: é preferível fazer boa medicina, com base em indicações e condutas clínicas de cunho científico, informar bem e desenvolver boas relações interpessoais com pacientes e familiares, do que fazer uma “medicina defensiva”, com excessiva preocupação com futuras ações legais. Este capítulo não foi elaborado por especialistas na área da ética ou do direito. Ele traz a visão de psiquiatras que se interessam por aspectos éticos e legais da interconsulta. Longe de tentar esgotar o assunto, destacam-se algumas situações com frequência encontradas no hospital geral, que são pouco abordadas em manuais de psiquiatria escritos em nosso país.

DILEMAS ÉTICOS

Quatro princípios morais encontram-se na base da ética médica: respeito pela autonomia, não maleficência, beneficência e justiça. Os dilemas éticos nascem do conflito entre esses princípios, os quais sofrem a influência de aspectos legais, religiosos e econômicos.¹

A autonomia de um paciente – e, portanto, sua decisão – pode ser questionada por uma das partes envolvidas em seu cuidado, quando se suspeita que um transtorno mental possa estar prejudicando a capacidade do paciente para discernir, julgar e agir.

Os pacientes podem recusar medidas terapêuticas julgadas pelos médicos como necessárias porque obedecem a crenças culturais ou religiosas. Não podem, é claro, ser declarados incapazes somente por isso. Glickman² exemplifica com a situação em que um homem se atira de um prédio para fugir de um incêndio. O paciente que se nega a certos tratamentos e procedimentos é como esse homem: ele está assumindo um risco não para se matar, mas para se livrar do que ele julga ser uma ameaça maior.

O problema criado, para o médico, pela recusa dos pacientes que seguem a religião Testemunhas de Jeová em permitir a transfusão de sangue é aqui abordado como exemplo de dilema ético. Esse tema tem dado margem a intensa discussão.³ Os médicos aceitam que seus pacientes se recusem a receber quimioterapia ou cirurgias oncológicas ou mesmo de revascularização miocárdica de modo menos martirizante.⁴ No caso da recusa à transfusão, no entanto, muitos médicos se revoltam, comparando a recusa ao suicídio. Outros esforçam-se em respeitar os preceitos do paciente.⁵ Na realidade, as Testemunhas de Jeová não desejam a morte, e, sim, que sejam utilizados todos os meios para impedi-la, exceto a transfusão de sangue.

Há uma tendência, da qual compartilhamos, a respeitar os direitos individuais do paciente maior de idade e competente de recusar tratamentos (princípio da autonomia).⁶ “A moral e a ética evoluem na sociedade porque, em algum momento, alguém pensou diferente, defendeu suas ideias, promovendo aceitação e mudanças de conceitos.”⁷

Em muitas situações de dilema ético, o interconsultor será um facilitador da comunicação. Ao diminuir o nível de angústia das pessoas envolvidas nas difíceis decisões que permeiam a prática médica, ele favorecerá a tomada de decisões. É importante não estar sozinho, nem confiar demais no “bom senso” pessoal. Em casos de maior dificuldade, é recomendável discutir sobre eles com outros membros da equipe de interconsulta, da diretoria clínica, bem como com colegas versados em aspectos éticos e jurídicos.⁸

SIGILO MÉDICO

Do ponto de vista legal, o segredo profissional é a obrigação devida às confidências recebidas pelo médico ou de tudo que vier a perceber ou a deduzir em sua relação com o paciente, cuja revelação possa lhe causar dano. Esse preceito ético estende-se a outros membros da equipe que assistem o paciente.

Há situações em que a quebra do sigilo médico pode fazer-se necessária a fim de proteger a saúde ou o bem-estar do paciente ou preservar um bem jurídico maior. Por exemplo, no caso de pacientes infectados pelo HIV, a revelação desse fato a um comunicante deve ser feita com a concordância e a colaboração do paciente. Todavia, se este se negar a consentir, e após ter havido esforços para movê-lo dessa posição, é lícito ao médico informar o comunicante. O que se está a proteger sobrepõe-se aos motivos pessoais do paciente, ocorrendo, assim, justa causa.⁹ Haverá justa causa quando a revelação for o único meio de conjurar perigo atual ou iminente e injusto para si ou para outro.

A violação do sigilo profissional é considerada crime quando houver intenção manifesta de praticá-la (dolo). Deixa de ser violação quando o paciente, ou seu representante legal, autoriza a revelação dos fatos considerados sigilosos. O médico deverá comunicar casos de danos corporais de origem obscura à autoridade competente (dever legal). Entretanto, não deverá expor seu paciente a processo criminal, como no caso de atender uma mulher que provocou um aborto.

Em relação a pressões sofridas pelos médicos de parte de autoridades judiciárias, para que revelem informações contidas no prontuário dos pacientes, Martins¹⁰ lembra que nossos tribunais têm entendido haver constrangimento ilegal por parte dessas autoridades quando requisitam, de hospitais ou médicos, prontuários e demais documentos sujeitos ao segredo profissional, sob a pena de responsabilidade e desobediência. Não se pode conceber, portanto, que o médico revele segredos ou elabore um laudo sobre as condições de seu paciente com o intuito de fornecê-lo à autoridade solicitante, a menos que solicitado pelo paciente – o que deverá ficar registrado.

No caso de interconsultas, a questão da confidencialidade merece considerações especiais. Por exemplo, deve-se sigilo ao paciente ou cumplicidade à equipe assistencial? Parece-nos que essa decisão depende da função exercida pelo interconsultor em dado momento do tratamento. Nos casos em que atende o paciente a pedido de um colega, recomendamos que o interconsultor, desde logo, deixe claro ao paciente que todas as informações imprescindíveis para seu diagnóstico e tratamento serão compartilhadas com o médico assistente. Isso porque algum aspecto da intimidade do paciente, revelado durante a interconsulta, pode ser decisivo na tomada de decisões sobre seu tratamento. Essa forma de proceder deverá evitar conflitos de interesse e tentativas de manipulação que possam surgir na tríade médico-paciente-psiquiatra.

Há algumas circunstâncias em que essa orientação deve ser flexibilizada, como, por exemplo, nos quadros psicóticos. Nas situações em que, após encerrada a avaliação, se estabelecer uma relação terapêutica distinta, como no caso da psicoterapia, questões relativas à confidencialidade deverão ser rediscutidas. Assim, a comunicação de novas informações, relativas à intimidade do paciente, ao médico assistente só poderá ser feita após autorização do paciente.

CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO

Quatro elementos devem estar presentes em um consentimento esclarecido: informação, entendimento, voluntariedade, capacidade do paciente para decidir.¹¹ O paciente precisa entender as informações e demonstrar capacidade para decidir-se livremente, sem coerção. Como veremos nos próximos itens deste capítulo, a dificuldade está em definir em quais casos a doença mental incapacita o paciente para uma decisão.

A informação dada ao paciente deve incluir:

- diagnóstico
- propósito, método, duração estimada e benefício do tratamento proposto
- possíveis dores ou desconfortos, riscos e efeitos colaterais do tratamento proposto
- modos alternativos de tratamento, inclusive aqueles menos invasivos

É preciso problematizar aqui quanto à maneira de informar, em sua extensão e profundidade. Há perigo em ambos os extremos – pouca informação e excesso de informação. Ao se adotar um nível de informações próximo ao que se transmitiria para uma audiência de médicos, alguns pacientes ficarão muito ansiosos e inseguros. Pouco entenderão, reagindo com pânico ou, no extremo oposto, com negação. Há situações em que o próprio paciente não quer ser muito informado e solicita isso ao médico. Outros, no entanto, desejam receber o máximo possível de informações.

Em geral, adota-se a estratégia de dar informações baseadas no padrão médio dos pacientes ou, então, uma estratégia caso a caso. O importante é estabelecer de quais informações fundamentais o paciente necessita para tomar sua decisão.

A Organização das Nações Unidas (ONU), em 1991, e o Brasil, em 1994, aprovaram os *Princípios para a proteção de pessoas acometidas de transtorno mental e para a melhoria da assistência à saúde mental*,¹² cuja leitura recomendamos. Entre vários princípios norteadores, encontra-se o seguinte:

Um procedimento médico ou cirúrgico de magnitude somente poderá ser realizado em uma pessoa acometida de transtorno mental quando permitido pela legislação nacional, quando se considerar que atende melhor às necessidades de saúde do usuário e quando receber seu consentimento informado, salvo os casos em que o usuário estiver incapacitado para dar esse consentimento, e o procedimento será autorizado somente após um exame independente [...]. O usuário, ou seu representante pessoal, ou qualquer pessoa interessada, terá o direito de apelar a uma autoridade independente, judiciária ou outra, no que concerne a qualquer tratamento que lhe tenha sido administrado.¹³

Há consenso acerca da necessidade de um responsável para autorizar o tratamento de um paciente incapacitado para o consentimento. A divergência está em torno de quem seria o responsável – o poder público (juiz), familiares, uma comissão composta por profissionais de saúde mental ou representantes de usuários do sistema de saúde pública.¹⁴

Na prática médica, em geral, há situações emergenciais em que é impossível a obtenção de um consentimento informado. Nesses casos de emergência, a decisão e a ação do médico são amparadas pelo que se chama de “estado de necessidade”. Toma-se por princípio que a aplicação do tratamento causou um mal menor do que o que teria ocorrido caso nenhum tratamento fosse

empregado. É importante, nesse caso, o registro detalhado das condições clínicas que levaram à decisão da equipe médica.

CAPACIDADE PARA RECUSAR TRATAMENTO

A capacidade de um paciente geralmente é avaliada em relação a uma área ou função específica, como a capacidade para recusar tratamento ou para cuidar de um bebê. Essa área, ou função específica, é que será avaliada. Não se trata, pois, de avaliar ou de declarar uma incapacidade absoluta. Só uma sentença judicial pode declarar a interdição (incapacidade total) de uma pessoa.¹⁵

Não basta ter um transtorno mental; é indispensável, pela lei, que a patologia mental interfira de tal forma no plano psicológico a ponto de impedir que a pessoa detenha a indispensável compreensão do significado, das implicações e das consequências, para si e para outrem, da recusa do tratamento.¹⁶ Muitos pacientes psiquiátricos encontram-se perfeitamente ajustados à vida social e, em tratamento, apenas excepcionalmente teriam ausência de discernimento ou impedimento de expressar plena e livremente sua vontade.¹⁷

No hospital geral, normalmente, o psiquiatra é chamado para: (1) determinar se o paciente está em condições mentais para, tendo compreendido a necessidade de um procedimento diagnóstico ou terapêutico, recusá-lo; ou (2) convencer um paciente a aceitar um procedimento proposto pela equipe médica. Nessa segunda situação, pode haver expectativas de que o psiquiatra consiga demover o paciente de sua recusa, fazendo-o decidir-se conforme o esperado pela equipe assistencial.¹⁸

O que faz, afinal, o psiquiatra? O Quadro 28.1 condensa os aspectos que acreditamos orientar as ações do interconsultor. Basicamente, ele verifica como se deu a transmissão e o processamento da informação, avalia se o paciente consegue ponderar os prós e contras de cada opção de tratamento e, não menos importante, atua como um facilitador e apoiador das decisões a serem tomadas.

QUADRO 28.1

O que deve fazer o psiquiatra chamado a opinar sobre um paciente que recusa tratamento

- Certifica-se de que foi dada ao paciente *informação adequada*.
- Avalia se o paciente reteve as informações e é capaz de ponderar as consequências das opções de tratamento ou não tratamento.
- Avalia se a *capacidade de julgamento* em relação a uma situação específica encontra-se limitada por um transtorno mental ou por ideias irrealistas.
- *Cria condições para uma tomada de decisão*, quer revertendo uma situação de incapacidade específica temporária (ao melhorar as condições mentais do paciente), quer diminuindo bloqueios de comunicação entre as partes envolvidas.
- *Auxilia a equipe assistencial* a aceitar a decisão do paciente.
- *Oferece apoio à família*, que precisa acatar o desejo do paciente ou tomar uma decisão, no caso de procedimentos com crianças ou com pessoas incapazes de decidir.

Entre as condições psiquiátricas que podem interferir na capacidade de avaliar e decidir sobre a própria situação clínica, incluem-se demência, *delirium*, psicoses, depressão grave, dor e uso de drogas psicoativas. No entanto, a maioria dos transtornos mentais não interfere na capacidade de avaliar e decidir sobre um procedimento médico.

Muitos pacientes que têm psicoses funcionais graves conseguem entender sua doença mental e sua necessidade de tratamento. Um paciente com esquizofrenia pode ser incapaz de se sustentar

economicamente, mas ter a capacidade de decidir sobre um procedimento a que poderá ser submetido. Mesmo em casos *delirium*, pode haver momentos de lucidez em que o paciente pode se manifestar conscientemente sobre sua recusa ao tratamento.

É importante lembrar, no entanto, que o paciente tem direito ao segundo melhor tratamento. Aceitar sua decisão e dar-lhe tempo adicional para elaborar a situação, bem como o agravamento de sua condição clínica, pode fazê-lo mudar de ideia. Muitos pacientes que recusam o tratamento proposto pelo médico, incluindo alguns que estejam incontestavelmente psicóticos, mudarão sua opinião e aceitarão o procedimento à medida que perceberem que sua condição clínica está se deteriorando. Mesmo os pacientes paranoides podem aceitar que seu maior inimigo, no caso de um problema clínico, é “interno”.

Na recusa de tratamento, surgem problemas quando um terceiro se diz detentor do desejo expressado pelo paciente, antes que este se encontre inconsciente ou incapaz de decidir. Para evitar esse impasse, o ideal é abordar certos assuntos com o paciente que, potencialmente, chegará a um estado terminal, por mais que essa conversa possa parecer penosa. Quando a equipe assistencial sentir-se pressionada, ou no caso de pacientes menores de idade, a decisão dos pais ou responsáveis poderá ser judicialmente questionada.

Avaliação do paciente

Quando um paciente recusa o tratamento proposto, o ideal é garantir um período de tempo para reflexão, até que se possa chegar a uma solução em que o paciente seja o mais favorecido. É imprescindível, em um primeiro momento, avaliar o paciente, tendo seu médico assistente ao lado. A presença deste último na primeira parte da entrevista resulta em mais vantagens do que desvantagens, como

1. O paciente sente-se reconfortado, e pode-se tomar isso como sinal de interesse por parte dele.
2. Muitos casos de recusa dão-se em situações de problemas na relação médico-paciente, e o psiquiatra pode averiguar melhor tal situação.
3. O psiquiatra não pode saber nem dar todas as explicações sobre a doença do paciente e os riscos e benefícios do tratamento.
4. O médico assistente terá acesso às mesmas informações passadas pelo paciente ao psiquiatra. Estará, assim, mais propenso a aceitar a conclusão do interconsultor.

Basicamente, ao avaliar o paciente, o psiquiatra deverá responder a quatro perguntas, resumidas no Quadro 28.2. O paciente capacitado a aceitar ou recusar um tratamento estará consciente de que algo está errado com sua saúde e do quão grave é sua situação; se mostrará informado sobre o tratamento proposto e sobre outras alternativas de tratamento, com respectivos riscos e benefícios; manifestará sua preferência; e apreciará corretamente as consequências de sua decisão.¹⁹ O Quadro 28.3 traz a sugestão de um roteiro de perguntas que podem ser feitas para o paciente.

QUADRO 28.2

Quatro perguntas que devem orientar a avaliação da capacidade de um paciente recusar ou consentir com um procedimento médico

Informação	O paciente foi suficientemente informado?
Apreciação	O paciente pode fazer uma apreciação da gravidade da situação, de seu prognóstico e dos riscos e benefícios das opções de tratamento, incluindo a opção de não se tratar?
Motivação	O que motivou o paciente a tomar essa decisão?
Transtorno mental	Há um transtorno mental que interfira em sua capacidade de decidir?

QUADRO 28.3

Roteiro de perguntas a serem feitas ao paciente que recusa tratamento

- Por que você foi internado?
- O que seu médico lhe disse sobre seu problema?
- O que você pensa sobre o que ele lhe disse?
- Que tratamento seu médico recomendou a você?
- Por quais razões seu médico recomendou esse tratamento?
- O que você pensa sobre essas razões?
- Você sabe quais são os riscos desse tratamento?
- Há outros tratamentos possíveis para seu problema?
- Quais são os pontos positivos e negativos desses outros tratamentos?
- No caso de você não fazer nenhum tratamento, o que poderia acontecer?
- O que você decidiu?
- O que o levou a tomar essa decisão?

Durante a entrevista, o psiquiatra poderá perceber que a recusa do paciente está muito relacionada ao medo da dor ou da morte, a medos irracionais, bem como à depressão. De forma alternativa, em relação a motivos baseados em falsas concepções, experiências passadas, ocorridas com o paciente ou com seus conhecidos, também podem ser motivo de recusa ao tratamento. O paciente poderá, também, ser hostil em relação à equipe assistencial ou mostrar-se indeciso, sendo incapaz de manifestar preferência por um ou por outro tratamento. É importante examinar cuidadosamente esses aspectos, pois são características do paciente passíveis de mudança por meio de esclarecimento e apoio psicológico.²⁰

A incapacidade atestada pelo psiquiatra deve ser provada, e as provas derivam das afirmações e do comportamento do paciente, bem como das informações fornecidas por terceiros. Deve ser documentada existência de um transtorno mental de tal gravidade que interfira na capacidade de o paciente tomar determinada decisão. O parecer deve ser claro, conciso, registrado no prontuário e dar respostas para as quatro perguntas que o psiquiatra tinha em mente (ver Quadro 28.2) ao iniciar a avaliação.²¹

ALTA A PEDIDO

As mesmas recomendações feitas para a eventualidade de recusa de tratamento, abordada anteriormente, devem ser seguidas quando da avaliação de pacientes que solicitam a alta, contrariando a recomendação médica (Quadro 28.4).

QUADRO 28.4

Quesitos a serem respondidos em casos de pacientes que solicitam alta a pedido

Se as perguntas correspondem com as respostas da coluna à direita do quadro, deve-se resguardar o direito do paciente a deixar o hospital contra recomendação médica.

■ O paciente é maior de idade?	SIM
■ O paciente tem competência civil para tomar uma decisão?	SIM
■ Está suficiente informado sobre sua doença?	SIM
Diagnóstico: descrição do problema	
Tratamento: natureza, risco e benefício	
Alternativas de tratamento: natureza, risco e benefício	
Prognóstico: consequências com e sem tratamento	
■ Entende as consequências da alta hospitalar?	SIM
■ Voluntariamente, recusa o tratamento hospitalar?	SIM
■ As lesões são autoinfligidas?	NÃO
■ A paciente está grávida?	NÃO

Fonte: Com base em Duñó Ambrós e Sans Torres.²²

Um estudo de Albert e Kornfeld²³ demonstrou como a interconsulta pode auxiliar nesses casos. Foram examinadas 28 solicitações de interconsulta psiquiátrica de pacientes que ameaçavam deixar o hospital. Foram encontradas três razões básicas para essas ameaças: medo desmedido, raiva e quadros psicóticos. A abordagem psiquiátrica foi capaz de auxiliar na mudança de posição dos pacientes. Dos 28 pacientes, 22 concordaram em continuar internados.

A alta a pedido deve ser analisada com prudência. Se consentida, o paciente e seu responsável devem assinar um documento após esclarecimentos feitos pelo médico. Em caso de alta a pedido, deve-se deixar uma porta aberta para a comunicação e o retorno do paciente à instituição, o que, de resto, se constitui em um direito da pessoa.

A denegação da alta a pedido deve ocorrer nos casos em que o paciente puder atentar contra sua integridade física, contra a de terceiros ou quando o risco de complicações fora do ambiente hospitalar for muito grande. Se o parecer da equipe médica contraindica a alta e, ainda assim, o paciente ou os familiares a exigirem, não restará alternativa senão acionar a autoridade judiciária.

Se o paciente se retirar sem assinar a alta a pedido, isso deve ser notificado no prontuário e assinado pelo médico e por testemunha. No caso de evasão de paciente com transtorno psiquiátrico, deve ser feito todo esforço para resgatá-lo. A família e a autoridade policial devem

ser comunicadas. A instituição poderá ser processada (*culpa in vigilando*), tendo de indenizar eventuais danos causados.

CAPACIDADE PARA CUIDAR DE UM BEBÊ

É comum o psiquiatra ser chamado para avaliar a capacidade de uma paciente vir a cuidar adequadamente de seu bebê recém-nascido. Isso ocorre quando a paciente tem história de doença mental, quando a equipe da enfermaria detecta alterações de comportamento e, sobretudo, nos casos em que a paciente vive sozinha ou não tem uma relação estável ou não conta com supervisão adequada nos cuidados necessitados pelo bebê.

Nesse tipo de interconsulta, o psiquiatra manterá em mente as seguintes tarefas principais:

- proteger a criança
- proteger a mãe
- diminuir a culpa da equipe assistencial

É crucial obter e registrar o maior número possível de informações sobre os planos da paciente para seu futuro e o do bebê, avaliar suas condições mentais, físicas e financeiras; se tem residência fixa; entrevistar familiares; dedicar um tempo a observar a relação mãe-bebê; averiguar, junto à enfermagem e a outras pacientes que dividam o mesmo quarto, como tem-se dado a interação da mãe com a criança. Deve-se lembrar, nesse caso, que, em um ambiente estruturado, como o da enfermaria de uma maternidade, a paciente poderá se comportar adequadamente. No entanto, após a alta, poderá ser incapaz de se organizar e cuidar da criança.

A declaração de incapacidade da mãe provoca muita emoção. É difícil aceitar que a maneira de assegurar que o bebê tenha um futuro melhor seja separá-lo de sua mãe natural e transferi-lo para um abrigo. Deve-se escolher a opção que menos causará danos. A paciente pode não entender que estamos tentando protegê-la de sua incapacidade de cuidar de seu filho. Pode deprimir-se e angustiar-se por perder o bebê, mas é preciso considerar que poderá sentir-se pior, um dia, se for a causadora da morte de seu filho.

Além disso, nem todos da equipe estarão de acordo com a opinião do psiquiatra. Alguém pode até aceitar a incapacidade de a paciente cuidar do bebê, mas não se conformará com a solução de separar a criança e enviá-la a uma instituição. Na tentativa de lidar com essas dificuldades, recomenda-se a realização de uma reunião, na qual os membros da equipe assistencial e o interconsultor possam compartilhar suas ideias e seus sentimentos.

INTERNAÇÃO INVOLUNTÁRIA

Se um psiquiatra determina que um paciente deve ser internado, e este não aceita a determinação, devem ser cumpridas as normas legais que regem a internação involuntária, de acordo com a Lei nº 10.216, de 2001, e a Portaria nº 2.391, que a regulamentou, de 2002.^{24,25} Esse tipo de internação pode ocorrer em situações ordinárias ou em situações de emergência. No primeiro caso, deve ser solicitada uma autorização judicial prévia. Nas internações de emergência, deve-se, no prazo de 72 horas, comunicar o caso às autoridades judiciais.

É preciso diferenciar internação involuntária de internação compulsória (esta última é decretada por autoridade judicial), pois, às vezes, esses termos são impropriamente utilizados como sinônimos. Há também a possibilidade de um juiz, por pressões de familiares, autorizar uma internação involuntária, e o médico do hospital não considerar adequado esse tipo de tratamento. O médico não incorrerá em delito se não internar o paciente, visto que o juiz somente autorizou, e não ordenou, a internação.

Sob o ponto de vista ético, na internação involuntária, o princípio da proteção do paciente e da sociedade entra em choque com o princípio da liberdade e da privacidade pessoais. Quando o paciente é um perigo para si ou para os outros ou não é capaz de cuidar de si mesmo, consideram-se o melhor interesse e a periculosidade. O critério de periculosidade, certamente, não é perfeito, mas é o que melhor pode ser defendido perante um juiz ou diante de um júri constituído por leigos.²

Na avaliação do paciente, duas questões devem ser respondidas:

- O paciente tem um transtorno mental?
- Em caso afirmativo, isso o incapacita para se decidir sobre a internação a ponto de pôr sua vida, ou a de outras pessoas, em perigo?

Se as duas respostas forem positivas, e o médico não proceder a uma internação, ele estará cometendo um erro médico. Em geral, as situações que levam a uma internação involuntária relacionam-se a quadros psicóticos, confusionais, de oligofrenia ou decorrentes do uso abusivo de álcool e drogas e risco de suicídio.

Há amparo legal para se proceder à internação involuntária a fim de evitar um suicídio. O Artigo 146 do Código Penal brasileiro,²⁶ sobre constrangimento ilegal, exclui, entre os crimes contra a liberdade pessoal, as intervenções médicas ou cirúrgicas sem o consentimento do paciente em casos de “iminente perigo de vida”, bem como de “coação exercida para impedir o suicídio”.

CONTENÇÃO FÍSICA

A contenção física é um procedimento usado na psiquiatria com pacientes com intensa inquietude e alto risco de comportamento violento. O procedimento não deve ser considerado um evento banal e de pouca repercussão entre os pacientes. Deve haver orientação do paciente sobre o caráter terapêutico – não punitivo – do procedimento, bem como comunicação com o responsável pelo paciente sobre a razão da contenção.

O Capítulo 13, sobre agitação psicomotora, aborda os detalhes técnicos, notadamente os cuidados para não ferir e minimizar a faceta violenta da contenção física. Em síntese, a equipe terapêutica deve estar articulada e treinada para eventuais episódios de agressividade. O ideal é que cada serviço redija um documento regulamentando o procedimento. É recomendável manter o paciente sob contenção pelo menor período possível. O registro do procedimento deve denotar o cuidado efetivamente prestado por médico e enfermagem ao longo do período em que o paciente se encontrar contido.²⁷

De acordo com parecer do Conselho Federal de Medicina²⁸ e do Conselho Regional de Medicina do Estado de São Paulo (CREMESP),²⁹ a contenção precisa ser prescrita por médico, registrada em prontuário e ser realizada quando ela for o meio mais adequado para prevenir dano imediato ou iminente ao próprio paciente ou a terceiro. De acordo com o Conselho Federal de Enfermagem, o enfermeiro também pode prescrever a contenção.³⁰

MORTE DIGNA, EUTANÁSIA E SUICÍDIO ASSISTIDO

É incorreto dizer que um paciente está “fora de possibilidade terapêutica”. Deve-se lembrar que o paciente sem chance de cura sempre terá a possibilidade de receber tratamento paliativo para aliviar alguns de seus incômodos.

De modo geral, pensa-se que uma pessoa adoentada teve uma “boa morte” se, no processo do morrer, recebeu conforto físico, emocional e espiritual de familiares, de amigos e das pessoas que dela cuidaram. Segundo a Organização Mundial da Saúde (OMS), um morrer adequado dá-se quando o paciente, familiares e cuidadores não passam por sofrimento que poderia ser evitado, quando está de acordo com as aspirações do paciente e de seus familiares e quando está em conformidade com padrões culturais, éticos e clínicos.³¹

Weisman³² listou quatro critérios para definir um morrer adequado, a saber:

- Os conflitos pessoais, como o temor em relação à falta de controle, devem ser reduzidos ao mínimo.
- O indivíduo deve manter seu senso de identidade.
- Relacionamentos mais próximos devem ser incrementados ou, no mínimo, mantidos, e, se possível, com a resolução de eventuais conflitos.
- A pessoa deve ser capaz de estabelecer e tentar alcançar alguns objetivos significativos e condizentes com sua condição, a fim de manter um sentimento de continuidade em relação ao futuro.

Um paciente em fase terminal de doença, às vezes, pede que se interrompam os procedimentos capazes de prolongar a vida. A equipe médica poderá, então, solicitar a avaliação do psiquiatra, que avaliará a capacidade de discernimento do paciente, em relação a este não ter algum transtorno mental que prejudique seu julgamento. Sabe-se, por exemplo, que, com frequência, a depressão se associa ao desejo de morrer. Há evidências de que, nesses casos, o desejo de morrer diminui consideravelmente entre os que respondem ao tratamento antidepressivo.³³

Se o paciente estiver consciente e com pleno discernimento, sua decisão deverá ser respeitada, o que é amparado ética e juridicamente. Nesse caso, o psiquiatra deverá apoiá-lo e facilitar as condições para um morrer adequado, bem como acolher a angústia de profissionais e familiares que se opõem à decisão do paciente.

A situação descrita não deve ser confundida com eutanásia, que é o ato de, deliberadamente, findar a vida de um paciente, por decisão própria ou a pedido deste ou de um familiar. Isso não impede o médico de respeitar o desejo do paciente de deixar que o processo natural da morte siga seu curso na fase terminal da doença.³⁴

No Brasil, em 2006, o Conselho Federal de Medicina promulgou a Resolução nº 1.805/06,³⁵ que regulamenta o atendimento ao paciente em fase terminal:

Art. 1º É permitido ao médico limitar ou suspender procedimentos e tratamentos que prolonguem a vida do doente em fase terminal, de enfermidade grave e incurável, respeitada a vontade da pessoa ou de seu representante legal.

Tal resolução, ainda em vigor, provocou muitos questionamentos, pois, de forma equivocada, foi considerada uma indução à eutanásia, que é um procedimento considerado antiético e proibido no País. Na realidade, o que ela permite é a ortotanásia. No Brasil, a eutanásia é crime.

Em contraposição, a obstinação terapêutica, que prolonga o sofrimento, afronta o princípio da não maleficência, levando à distanásia. Entende-se que o médico não está obrigado a prolongar, por meios artificiais, o processo de morte do paciente sem que este tenha requerido que o médico assim agisse.³⁶

Um testamento vital pode ser feito por qualquer pessoa, a fim de detalhar os procedimentos terapêuticos que aceita ou não em uma situação em que não haja esperança de sobrevivência. O registro pode ser feito em cartório ou no prontuário médico. O Quadro 28.5 traz a diferença entre os conceitos aqui abordados.

QUADRO 28.5

Definições relativas ao morrer em fase terminal da doença

Termo	Definição
Ortotanásia	Permite-se que o processo de morrer ocorra a seu tempo, sem abreviação ou prolongamento artificial da vida.
Eutanásia	Prática pela qual se busca, deliberada e ativamente, por decisão própria ou a pedido, findar a vida de um doente incurável.
Distanásia	Morte lenta, com sofrimento e agonia. A vida é artificialmente prolongada por obstinação terapêutica.
Suicídio assistido	O médico, ou outra pessoa, deliberadamente, orienta e fornece os meios para que o paciente se mate.

A tentativa ou o ato de levar a cabo o suicídio não é crime, porém pode ser punido civilmente (cobertura de gastos com assistência médica pode ser negada, seguro de vida não é pago). A indução, a cooperação ou a execução do suicídio são consideradas delitos. Casos de suicídio que cheguem ao conhecimento do médico devem ser comunicados à autoridade policial.

O suicídio assistido é permitido em poucos países.^[INT] Médico e paciente precisam estar de acordo sobre a natureza e a gravidade de um “sofrimento insuportável e sem perspectiva de melhora”, o que tem provocado controvérsias.^{33,37} Com o amparo da lei, o paciente é orientado e recebe drogas capazes de levar à morte. Apenas o paciente pode dar esse último passo.

A participação do psiquiatra em processos de suicídio assistido é cercada de questionamentos, desde os relacionados ao tipo de capacitação técnica requerida de um avaliador em casos de solicitação de suicídio assistido, até os relacionados aos conflitos de interesse e à ética. Em nenhum país que aceita o suicídio assistido a avaliação psiquiátrica é obrigatória, salvo quando o paciente sofre de um transtorno mental, comórbido ou exclusivo, que possa prejudicar a capacidade de julgamento, notadamente em casos de depressão.

A não obrigatoriedade da avaliação psiquiátrica é uma forma de evitar o que se entende como “psiquiatrização” da intenção manifestada pelo paciente. Em oposição a essa visão, há os que defendem tal obrigatoriedade, por considerarem que o psiquiatra avaliaria melhor a motivação do paciente, bem como em que medida um possível transtorno mental estaria comprometendo-lhe a decisão.^{33,38}

Algumas recomendações aos interconsultores diante de conflitos éticos e legais estão resumidas no Quadro 28.6.

QUADRO 28.6

Recomendações ao interconsultor diante de conflitos éticos e legais

- Determinar com clareza os motivos explícitos e implícitos da solicitação de interconsulta.
- Inteirar-se completamente da situação clínica a ser avaliada, não deixando de ouvir, com atenção, respeito e sem julgamento, o que o paciente pensa.
- Discriminar os aspectos legais envolvidos.
- Determinar possível conflito entre o que se considera uma boa prática clínica e a legislação.
- Procurar envolver na discussão os elementos-chave da equipe assistencial, a equipe da interconsulta, o diretor clínico e o assessor jurídico do hospital.
- Afastar as partes envolvidas de uma mentalidade de crise, com decisões a serem tomadas contra o relógio. Procure ganhar algum tempo para que as pessoas possam pensar mais claramente e para que os conflitos possam ser solucionados.
- Levantar em conta os traços de personalidade do médico assistente e do paciente.
- Conhecer os familiares próximos do paciente, o que eles pensam, suas apreensões, se estariam preparados para assumir responsabilidades quanto a decisões sobre tratamento.
- Procurar ser um facilitador da comunicação entre médico, paciente e familiares.
- Verificar os conflitos encobertos que possam estar correndo entre paciente e equipe assistencial, procurando áreas livres de conflito, nas quais as partes poderiam concordar.
- Documentar no prontuário o quadro clínico do paciente, como ele compreende a situação, como julga os fatos, sua capacidade para consentir ou negar tratamento, bem como a evolução do caso.
- Manter a objetividade: seu papel é avaliar, tão precisamente quanto possível, a capacidade do paciente de autorizar/recusar um procedimento proposto. Seu papel não é fazer prevalecer a verdade, ou mover-se segundo preocupações da equipe assistencial.
- Valorizar-se dessa interconsulta para transmitir ao médico que ele tem pouco o que temer da Justiça, e, para o paciente, que ele tem pouco a temer de seu médico.

Fonte: Com base em Schouten.³⁹

MÁ PRÁTICA^[NT]

O erro médico é o mau resultado involuntário, oriundo de falhas estruturais – quando as condições de trabalho e os equipamentos forem insuficientes para o bom atendimento – ou de trabalho médico danoso ao paciente (*mala praxis*), aqui denominado má prática, que possa ser caracterizado como imperícia, imprudência ou negligência.⁴⁰

No Brasil, a Constituição Federal, de 1988,⁴¹ e o Código de Defesa do Consumidor, de 1990,⁴² ampliaram as possibilidades de demandas legais relacionadas à responsabilidade civil de médicos e instituições de saúde. Tanto no Brasil quanto nos demais países latinos, sempre que houver culpa do médico, os danos resultantes da atividade médica obrigam o profissional ao ressarcimento civil e penal. No Código Civil aprovado em 2002, os artigos capitais sobre a responsabilidade civil do médico são o 186 e o 927:

Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito (Artigo 186).⁴²

Aquele que por ato ilícito causar danos a outrem é obrigado a repará-lo [...] Haverá obrigação de reparar o dano, independentemente da culpa, nos casos especificados em lei, ou quando a atividade normalmente desenvolvida pelo autor do dano implicar, por sua natureza, risco para os direitos de outrem (Artigo 927).⁴²

O Código Civil⁴² traz a hipótese de responsabilidade objetiva para todas as profissões que, por sua natureza, criem o risco de danos a terceiros^[NT]. No entanto, alguns especialistas acreditam não ser possível, a partir do Artigo 927, considerar objetivo o caráter subjetivo da responsabilidade médica (ou seja, a obrigação de reparar o dano independentemente da prova de culpa). O risco não é criado pela atividade do médico, que é considerada uma obrigação de meios, e não de fins. A responsável pelo risco é a doença. O médico emprega os meios possíveis para corrigir o desvio da saúde física e mental do paciente.^{43,44}

No campo dos processos judiciais devidos a acusações de erro médico e de má prática, citam-se, com frequência, os Estados Unidos. É preciso lembrar que a simples transposição da doutrina norte-americana para o Brasil não é apropriada. O direito norte-americano não apresenta uma codificação de leis, diferentemente da maioria dos países latinos. O sistema baseia-se em decisões de tribunais e de juízes, fundamentando-se no precedente legal e nas regras de evidência.⁴⁵

O senso prático dos estadunidenses construiu, ao longo do tempo, uma doutrina de reparação de dano médico baseada na noção de responsabilidade objetiva; ou seja, para a caracterização da culpa, não se torna necessária a intenção, basta a simples voluntariedade da conduta. A responsabilidade objetiva surgiu por haver muita desigualdade de recursos entre vítima e autor do dano. O legislador percebeu que, muitas vezes, a obrigação de indenizar existe, mas é muito difícil para a vítima provar a culpa do ofensor (negligência, imprudência ou imperícia). Por isso, desenvolveu-se o conceito de responsabilidade objetiva, baseada na existência de risco.

O intuito de abranger todos os casos de dano e atender ao princípio social da reparação é o argumento principal daqueles que defendem a responsabilidade objetiva. Nesse caso, não se exige prova da culpa do médico; sua culpa por ter sido agente de uma ação que gera riscos é

presumida. Caberá ao profissional provar que atuou, no caso em questão, em conformidade com o padrão de sua especialidade (*lex artis*), não se desviando de um modelo ideal de conduta.⁴⁶

Há diversos casos em que o erro médico gera ações nas esferas civil e criminal, mas a responsabilidade criminal pressupõe que ocorra dolo ou culpa, ou seja, que o ato seja antijurídico e tipificado pelo Código Penal. Em casos de condenação criminal, não há necessidade de ação civil, pois a sentença criminal tem poder executivo na esfera cível; isto é, se o médico for condenado, automaticamente é gerada a obrigação de pagar indenização, a ser fixada pelo juiz da esfera cível.

Relação contratual

A relação entre médico e paciente é, implicitamente, contratual. A primeira consulta tem caráter probatório, após a qual uma das partes poderá decidir não empreender o tratamento. Considera-se que, ao assistir o doente, o médico assume obrigação de meio, e não de resultado (não se compromete a curar). O objeto do contrato é a sua própria atividade.⁴⁰

Em alguns casos, entretanto, pode-se presumir a culpa (responsabilidade objetiva), quando se espera uma obrigação de resultado, como no caso de cirurgias plásticas estéticas, exames de laboratório e, no caso de hospitais, quanto às ações de seus funcionários.⁴⁷ Há autores, no entanto, que consideram que não há obrigação de resultado mesmo em cirurgias estéticas, e sim obrigação de meio, isto é, o profissional tem de comprovar que usou todos os instrumentos possíveis para alcançar o resultado esperado. Essa é a jurisprudência dominante.

O contrato terapêutico estabelecido entre médico e paciente pressupõe confidencialidade, cooperação e responsabilidades compartilhadas. Se essa relação não puder ser estabelecida com um paciente devido ao seu estado mental, deve-se estabelecer com um familiar ou com outra pessoa próxima ao paciente. Se a relação estabelecida for por razões não terapêuticas, como no caso da perícia forense, isso deve ser claramente explicado ao paciente.

Respeitadas certas limitações (risco de morte, disponibilidade de outro profissional), a condição de autonomia do médico permite-lhe recusar a assumir um tratamento. Ou seja, o médico pode romper o contrato estabelecido com o paciente. Geralmente, isso ocorre em situações de conflito, de recusa a acatar decisão do médico (submeter-se a um procedimento ou tratamento que o médico julga imprescindível), de falta de pagamento de honorários ou de falta de observância às recomendações médicas – casos em que o profissional se sinta constrangido para continuar atendendo o paciente. Há que se tomar o cuidado de, em tais situações, orientar o paciente, facilitando-lhe o acesso a outro serviço ou profissional.⁶

Há uma máxima jurídica que diz “o que não está nos autos não está no mundo”. O registro em prontuário é a base da defesa do médico. É essa a principal fonte de informações em casos de litígio. O receio de que o paciente ou terceiros poderão ler o prontuário não deveria impedir o médico de documentar o ocorrido no tratamento. Ao contrário, recomenda-se ao médico que escreva com a expectativa de que o paciente leia suas anotações.⁴⁸ Recomendações específicas sobre a forma de fazer registros de interconsultas em prontuários encontram-se no Capítulo 8.

Responsabilidades na interconsulta psiquiátrica

O médico assistente tem a responsabilidade primária sobre o tratamento do paciente. Com mais frequência, a interconsulta é solicitada para uma avaliação especializada, e não para assumir o tratamento do paciente, pois o psiquiatra tem pouco, ou nenhum, controle sobre a equipe assistencial. Tais circunstâncias, embora diminuam a probabilidade de o interconsultor ser responsabilizado, não deveriam deixá-lo em uma posição excessivamente confortável.

Na atividade de interconsulta, atuam os seguintes princípios: o da confiança e o da divisão de tarefas. Um profissional deve confiar nas opiniões e no trabalho do outro. Esses princípios estendem-se a todos os profissionais da equipe assistencial, cuja eleição para tomarem parte da tarefa assistencial é de responsabilidade do líder da equipe e da direção clínica do hospital. Algumas responsabilidades serão assumidas individualmente; outras, compartilhadas.

É fundamental que, terminada a fase de avaliação do paciente pelo interconsultor, definam-se as responsabilidades de cada um. Por exemplo, na situação em que o interconsultor prescreve um psicofármaco, espera-se, naturalmente, que este monitore os efeitos desse tratamento. Pode-se, no entanto, atribuir essa responsabilidade ao médico assistente, mediante acordo. Obviamente, o psiquiatra será imputável se assumir que acompanhará o paciente e deixar de fazê-lo.

As situações de maior vulnerabilidade são aquelas em que tanto o médico assistente quanto o interconsultor acreditam que o outro tem a responsabilidade primária sobre um tratamento instituído ou, em outro exemplo, a responsabilidade de comunicar a autoridade judicial sobre uma suspeita de violência (ou negligência) contra uma criança, um idoso ou um doente mental internado.

Nos casos em que o interconsultor assume responsabilidades diretas, assume, também, em termos legais, os mesmos riscos do psiquiatra que atende um paciente de forma independente, em seu consultório, por exemplo. Um psiquiatra não deverá sofrer sanções penais por não ter detectado uma arritmia cardíaca em um paciente deprimido visto em interconsulta, mas poderá, sim, ser condenado se prescrever um antidepressivo contraindicado para tal paciente.

Na supervisão de estudantes e de médicos-residentes, mesmo que não veja o paciente, o psiquiatra é responsável (princípio do *respondeat superior*). Conclui-se que ter examinado o paciente é condição fundamental para garantir que a supervisão não foi negligente.⁴⁹

Um profissional (médico assistente ou psiquiatra interconsultor) que resolva desconsiderar o que foi recomendado por outro profissional deverá ter boa justificativa para tanto e assumirá a responsabilidade pelas consequências de sua forma de proceder. Em tais impasses, esgotadas as possibilidades de “negociação” (ver Cap. 8, sobre aspectos técnicos da interconsulta), o psiquiatra deve recorrer à direção clínica do hospital e comunicar sua opinião ao paciente ou aos familiares, sempre na intenção de proteger o paciente, garantindo-lhe o melhor tratamento.

O princípio norteador, nesses casos, é o de não quebrar a relação fiduciária (do latim, *fiducia*, que significa confiança, segurança) com o paciente. O médico tem essa responsabilidade ética e legal por causa da confiança nele depositada pelo paciente, por cujo bem-estar e interesse deve zelar.⁴⁹

Problemas legais mais frequentes

A maioria dos comportamentos penalmente relevantes em interconsulta é de imprudência. Assim, o profissional não age com dolo ou falta, mas infringe normas da boa prática profissional, não observando a *lex artis* da especialidade. Para ser imputado, deverá haver relação de causalidade entre sua conduta e o resultado observado no paciente.

As faltas que, com mais frequência, poderão recair sobre o psiquiatra interconsultor podem ser divididas em três grupos:

1. *Atuação inadequada na avaliação e no manejo do paciente.* Nesse caso, além do psiquiatra, também o médico que solicitou a interconsulta, assim como a instituição hospitalar, serão responsáveis, segundo a noção de *culpa in eligendo*, por terem escolhido e confiado em um profissional que se mostrou inadequado. O hospital e a diretoria clínica também terão responsabilidade civil subsidiária sobre omissões ou atos ocorridos. Podem, por exemplo, ser responsabilizados por *culpa in vigilando* se um paciente internado cometer suicídio.
2. *Falhas de comunicação.* Essa falta pode ser evitada por meio de contato regular com o paciente, com a equipe assistencial e com o registro das recomendações no prontuário. Outro cuidado especial deve ser tomado com as “consultas de corredor”. As opiniões “em tese” que emitimos podem, na realidade, prejudicar um paciente cuja avaliação conscienciosa terá sido negligenciada.
3. *Falhas no acompanhamento do paciente.* O interconsultor deve “incluir” em sua agenda horários reservados para o seguimento, comunicar esses horários ao paciente e à equipe assistencial, viabilizar substituto quando de férias e feriados e deixar registrado o encerramento de sua participação no caso. Há o perigo de o interconsultor “relaxar” nas responsabilidades devidas ao paciente e deixar de acompanhá-lo, contando com a diligência e a capacidade do médico assistente.

A maioria das ações contra médicos está pautada na falta de informação. Por isso, é essencial que sejam dadas as devidas orientações ao paciente e sua família de maneira dedicada, para que se esgotem as lacunas que possam gerar qualquer tipo de desconfiança. O bom relacionamento com o paciente e com os familiares é um esteio para que sejam evitadas querelas posteriores. Há, inclusive, autores que consideram que a responsabilidade do médico esteja pautada não apenas nos instrumentos de seu ofício, mas também na obrigação de informar paciente ou familiares sobre as condutas, prós e contras, prognóstico, etc.

É preferível fazer boa medicina, arraigada em indicações e condutas clínicas baseadas em evidências científicas, informar bem e desenvolver boas relações interpessoais com pacientes e familiares, a fazer uma “medicina defensiva”, com excessiva preocupação com futuras ações legais.

REFERÊNCIAS

1. Beauchamp TL, Childress JF. Princípios de ética biomédica. 4. ed. São Paulo: Loyola; 2002.
2. Glickman LS. Psychiatric consultation in the general hospital. New York: Marcel Dekker; 1980.
3. Conselho Federal de Medicina (BR). Resolução nº 1021, de 28 de setembro de 1980 [Internet]. Brasília: CFM; 1980 [capturado em 19 jan. 2017]. Disponível em: http://www.portalmédico.org.br/resolucoes/CFM/1980/1021_1980.htm.
4. Kipper DJ, Hossne WS. Caso clínico. Bioética. 1996;4(1):97-105.
5. Mann MC, Votto J, Kambe J, McNamee MJ. Management of the severely anemic patient who refuses transfusion: lessons learned with the care of a Jehovah's Witness. Ann Intern Med. 1992;117(12):1042-8.
6. Segre M, Cohen C. Bioética. São Paulo: EDUSP; 1995.
7. Coutinho LM. Responsabilidade ética, penal e civil do médico. Brasília: Brasília Jurídica; 1997.
8. Nogueira-Martins LA, De Marco MA, Manente MLF, Noto JRS, Bianco SM. Dilemas éticos no hospital geral. Bol Psiquiatr. 1991;24(1/2):28-34.
9. Conselho Regional de Medicina (SP). Arquivos do Conselho Regional de Medicina do Estado de São Paulo. São Paulo: CREMESP; 1991.
10. Martins GZ. Segredo médico. J Med CFM. 1999;116:6.
11. Hewlett S. Consent to clinical research – adequately voluntarily or substantially influenced? J Med Ethics. 1996;22(4):232-7.
12. Organização das Nações Unidas. A proteção de pessoas acometidas de transtorno mental e a melhoria da assistência à saúde mental [Internet]. ONU; 1991 [capturado em 19. jan. 2017]. Disponível em: http://pfdc.pgr.mpf.mp.br/atuacao-e-conteudos-de-apoio/legislacao/saude-mental/principios_protecao_pessoas_transtorno_mental_onu.
13. Conselho Regional de Medicina (SP). Ética médica. São Paulo: CREMESP; 1996.
14. Lovisi GM, Lima LA, Morgado AF. Limitações do consentimento informado em psiquiatria. Informação Psiquiátrica. 1997;16(3):98-101.
15. Teixeira EH, Barros DM. Perícia em Direito Civil. In: Barros MB, Teixeira EH. Manual de perícias psiquiátricas. Porto Alegre: Artmed; 2015. p. 37-67.
16. Taborda JGV, Mecler K, Fridman S, Moraes T. Avaliação da capacidade civil e perícias correlatas. In: Taborda JGV, Chalub M, Abdalla-Filho E. Psiquiatria forense. Porto Alegre: Artmed; 2004. p. 177-90.
17. Moraes TM. Avaliação da capacidade civil. In: Brasil MAA, Botega NJ, Hetem LAB. Programa de educação continuada da Associação Brasileira de Psiquiatria (PEC-ABP). Rio de Janeiro: ABP; 2010. p. 249-60.
18. Katz M, Abbey S, Rydall A, Lowy F. Psychiatric consultation for competency to refuse medical treatment. Psychosomatics. 1995;36(1): 33-41.

19. Appelbaum P, Grisso T. Assessing patients' capacities to consent to treatment. *N Engl J Med*. 1988;319(25):1635-8.
20. Sullivan MD, Youngner SJ. Depression, competence, and right to refuse lifesaving medical treatment. *Am J Psychiatry*. 1994;151(7):971-8.
21. Gutheil TG, Bursztajn H. Clinicians' guidelines for assessing and presenting subtle forms of patient incompetence in legal settings. *Am J Psychiatry*. 1986;143(8):1020-3.
22. Duñó Ambrós R, Sans Torres J. La inadaptación al hospital y el alta voluntaria. In: Rojo Rodes JE, Cirera Costa E. *Interconsulta psiquiátrica*. Barcelona: Masson; 1997. p. 571-5.
23. Albert HD, Kornfeld DS. The threat to sign out against medical advice. *Ann Intern Med*. 1973;79(6):888-91.
24. Brasil. Lei nº 10.216, de 06 de abril de 2001 [Internet]. Brasília: Casa Civil; 2001 [capturado em 19 jan. 2017]. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/leis_2001/110216.htm.
25. Ministério da Saúde (BR). Portaria 2.391, de 26 de dezembro de 2002 [Internet]. Brasília: MS; 2002 [capturado em 19 jan. 2017]. Disponível em: https://www.defensoria.sp.def.br/dp_esp/Repositorio/33/Documentos/PORTARIA%20N%C2%BA%202391_GM%20%20EM%2026%20DE%20DEZEMBRO%20DE%202002.pdf.
26. Brasil. Decreto-lei nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940 [Internet]. Brasília: Casa Civil; 1940 [capturado em 19 jan. 2017]. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto-lei/Del2848.htm.
27. Gaskin CJ, Elsom SJ, Happel B. Interventions for reducing the use of seclusion in psychiatric facilities. *Br J Psychiatry*. 2007;191(4):298-303.
28. Conselho Federal de Medicina (BR). Resolução nº 1952, de 07 de julho de 2010 [Internet]. Brasília: CFM; 2010 [capturado em 19 jan. 2017]. Disponível em: http://www.portalmédico.org.br/resolucoes/cfm/2010/1952_2010.htm.
29. Conselho Regional de Medicina (SP). Consulta nº 175.956, de 2014 [Internet]. São Paulo: CREMESP; 2015 [capturado em 19 jan. 2017]. Disponível em: <http://cremesp.com.br/?siteAcao=Pareceres&dif=a&ficha=1&id=13176&tipo=PARECER&orgao=Conselho%20Regional%20de%20Medicina%20do%20Estado%20de%20S%3o%20Paulo&numero=175956&situacao=&data=28-04-2015>.
30. Conselho Federal de Enfermagem (BR). Resolução nº 427, de 8 de maio de 2012 [Internet]. Brasília: Diário Oficial da União; 2012 [capturado em 19 jan. 2017]. Disponível em: http://www.cofen.gov.br/resolucao-cofen-n-4272012_9146.html.
31. World Health Organization. WHO definition of palliative care [Internet]. Geneva: WHO; 2017 [capturado em 19 jan. 2017]. Disponível em: <http://www.who.int/cancer/palliative/definition/en/>.
32. Weisman AD. *On dying and denying: a psychiatric study of terminality*. New York: Behavioral Publications; 1972.
33. Breitbart W, Rosenfeld B, Gibson C, Kramer M, Li Y, Tomarken A, et al. Impact of treatment for depression on desire for hastened death in patients with advanced AIDS. *Psychosomatics*. 2010;51(2):98-105.

34. World Psychiatric Association. Human rights and professional responsibilities of physicians in documents of international organizations. Kiev: WPA; 1996.
35. Conselho Federal de Medicina (BR). Resolução nº 1.805, de 28 de novembro de 2006 [Internet]. Portal Médico; 2006 [capturado em 19. Jan. 2017]. Disponível em: http://www.portalmedico.org.br/resolucoes/cfm/2006/1805_2006.htm.
36. França GV. Comentários ao código de ética. 3. ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan; 2000.
37. Sá MFF. Direito de morrer: eutanásia, suicídio assistido. Belo Horizonte: Del Rey; 2000.
38. McCormack R, Fléchais R. The role of psychiatrists and mental disorder in assisted dying practices around the world: a review of the legislation and official reports. *Psychosomatics*. 2012;53(4):319-26.
39. Schouten R. Legal aspects of consultation. In: Stern TA, Fricchione GL, Rosenbaum JF. Massachusetts general hospital handbook of general hospital psychiatry. St. Louis: Elsevier; 1997. p. 437-66.
40. Diniz MH. O estado atual do biodireito. 9. ed. São Paulo: Saraiva; 2014.
41. Brasil. Constituição da República Federativa do Brasil de 1988 [Internet]. Brasília: Casa Civil; 1988 [capturado em 19 jan. 2017]. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicaocompilado.htm.
42. Brasil. Lei nº 8.078, de 11 de setembro de 1990 [Internet]. Brasília: Casa Civil; 1990 [capturado em 9 jan. 2017]. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L8078.htm.
43. Pereira LA. A medicina e os médicos no novo Código Civil [Internet]. Portal do Médico; 2003 [capturado em 19 jan. 2017]. Disponível em: http://www.portalmedico.org.br/jornal/jornais2003/Fev_Mar/pag_14.htm.
44. Souza NTC. Erro médico e o novo Código Civil [Internet]. Jus Navegandi; 2003 [capturado em 19 jan. 2017]. Disponível em: <https://jus.com.br/artigos/3845/erro-medico-e-o-novo-codigo-civil>.
45. Rojo Rodes J. Aspectos legales de la interconsulta psiquiátrica. In: Rojo Rodes JE, Cirera Costa E. Interconsulta psiquiátrica. Barcelona: Biblio STM; 1997. p. 599-616.
46. Kfoury Neto M. Responsabilidade civil do médico. São Paulo: Revista dos Tribunais; 1994.
47. Bittar CA. Responsabilidade civil médica, odontológica e hospitalar. São Paulo: Saraiva; 1991.
48. Wise MG, Rundell JR. Concise guide to consultation psychiatry. Washington: APA; 1988.
49. Garrick TR, Weinstock R. Liability of psychiatric consultants. *Psychosomatics*. 1994;35(5):474-84.

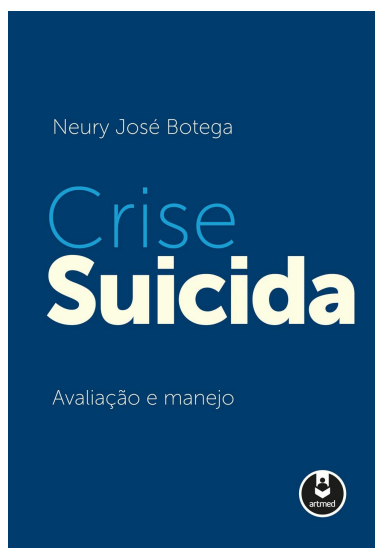
[países] A Holanda foi o primeiro país, em 2002, a legalizar a eutanásia e a descriminalizar o suicídio assistido. Holanda, Bélgica e Luxemburgo autorizam o suicídio assistido de uma pessoa que sofra de um transtorno mental causador de sofrimento insuportável e interminável, desde que ela mantenha a capacidade de discernimento. Na Suíça, uma famosa clínica oferece suicídio assistido em casos de doenças crônicas. Inúmeros cidadãos estrangeiros já recorreram a seus serviços para tirar a própria vida. Alemanha, Canadá e Colômbia são outros países que regulamentam o suicídio assistido, considerando-o uma

forma de solidariedade e respeito ao próximo, e não um crime. Nos Estados Unidos, o suicídio assistido é aceito no Oregon, desde 1997, e em alguns Estados em casos de fase terminal da doença. Em geral, a eutanásia é ilegal em países que permitem o suicídio assistido.³⁸

[MÁ PRÁTICA] Agradecemos a leitura crítica e as sugestões feitas por Karina Diniz Oliveira, nossa colega no Departamento de Psicologia Médica e Psiquiatria da Unicamp, também colaboradora deste livro.

[terceiros] Esse conceito é aplicável ao empregador que se beneficia de uma ocupação perigosa – por exemplo, empresas de construção civil cujos funcionários trabalham em locais altos, ou com materiais tóxicos. Pode, também, ser aplicado a hospitais, que têm obrigação de indenizar pacientes que sofreram prejuízo por falta de recursos básicos que impediram o médico de exercer adequadamente sua função.

Conheça também:



BOTEGA – Crise suicida

Sobre o Grupo A

O Grupo A está preparado para ajudar pessoas e instituições a encontrarem respostas para os desafios da educação. Estudantes, professores, médicos, engenheiros, psicólogos. Profissionais das carreiras que ainda não têm nome. Universidades, escolas, hospitais e empresas das mais diferentes áreas. O Grupo A está ao lado de cada um. E também está nas suas mãos. Nos seus conteúdos virtuais. E no lugar mais importante: nas suas mentes.

Acesse

0800 703 3444

sac@grupoa.com.br

Av. Jerônimo de Ornelas, 670

Santana

CEP: 90040-340 • Porto Alegre / RS

